

जयकृष्णादास आयुर्वेद ग्रन्थमाला

आयुर्वेदीय प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग

प्रसूतिवन्ध

प्रो. (कु०) प्रेमवती तिवारी

कोओं:डिनेटर आयुर्वेद संकाय

भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, प्रसूति-तन्त्र विभाग

एवं संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, का० हि० वि० वि०

गौरवभा ओरिद्यन्तानिधा

प्राच्य विद्या एवं दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशक तथा वितरक

वाराणसी

प्रकाशक

चौखम्भा ओरियन्टालिया

पो० बाक्स नं० १०३२

गोकुल भवन, के० ३७/१०९, गोपाल मंदिर लेन
गोलघर, मैदगिन

वाराणसी - २२१००९ (उ०प्र०)

E-mail: co@chaukhambha.com • info.covns@gmail.com

टेलीफोन : ०५४२-२३३३४७६, २३३४३५६

टेलीफैक्स : ०५४२-२३३४३५६

© चौखम्भा ओरियन्टालिया

संशोधित-परिवर्धित-नवीन

द्वितीय संस्करण : १९९९

पुनर्मुद्रित : २०१४

मूल्य ₹ : ४५०.००

प्रकाशकाधीन भारतीय कॉपीराइट ऐक्ट के तहत इस पुस्तक में प्रकाशित समस्त सामग्री स्वत्वाधिकारी प्रकाशक के पास सुरक्षित है। अतः कोई भी व्यक्ति या संस्था के लिए पुस्तक का नाम, फोटो, कवर डिजाइन इत्यादि को किसी भी तरह से तोड़-मरोड़कर आंशिक या पूर्ण रूप से किसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र में प्रकाशित करने के पूर्व प्रकाशक की अनुमति लेना अनिवार्य है। अन्यथा समस्त कानूनी हर्ज के जिम्मेवार होंगे।

चरक संहिता

महर्षिणा पुनर्वसुनोपदिष्टा तन्त्रिभ्योपाधिवेशनं प्रणीता चरक दृढबलाभ्यां प्रतिसंस्कृता
श्री चक्रपाणि दत्त विरचिता 'आयुर्वेद दीपिका' की 'आयुर्वेद' हिन्दी व्याख्या विभूषिता
'आयुर्वेद' हिन्दी व्याख्याकार वैद्य हरिश्चन्द्र सिंह कुशवाहा (एम. डी. आयुर्वेद संहिता)।
प्रथम भाग (सूत्रस्थान, निदानस्थान, विमानस्थान, शरीरस्थान एवं इन्द्रियस्थान)
द्वितीय भाग (चिकित्सा, कल्प तथा सिद्धिस्थान)

शालाक्य विज्ञान (सचित्र)

रवीन्द्रचन्द्र चौधरी (संपूर्ण)

ISBN : 978-81-7637-050-9 (Vol.-I)

ISBN : 978-81-7637-049-3 (Set)

मुद्रक : चारु प्रिन्टर्स, गोलघर, वाराणसी-२२१००९

JAIRISHNADAS AYURVEDA SERIES
NO. 49

ĀYURVEDIYA PRASŪTTANTRA EVAM STRĪROGA

PART I

PRASŪTTANTRA

(OBSTETRICS)

By

Prof. (Km.) PREMVAATI TEWARI

A. M. B. S.; Ph. D.

Coordinator Faculty of āyurveda
Ex. Head, Department of Prasūti-Tantra
and dean Faculty of āyurveda
Institute of Medical Sciences
B. H. U., Varanasi



CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

A House of Oriental and Antiquarian Books
VARANASI

Publishers:

CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

Post Box No. 1032

Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane

Golghar, Maidagin

VARANASI - 221001 (U.P.) (India)

E-mail: co@chaukhambha.com • info.covns@gmail.com

Telephone: 0542-2333476, 2334356

Telefax: 0542-2334356

© Chaukhambha Orientalia

Revised and Enlarged

Second Edition : 1999

Reprint : 2014

All rights reserved by the Publisher. No Part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopying recording or otherwise, with the prior permission of the Copy Right owners.

Kayacikitsa

The Principles and Practice (Āyurveda's Internal Medicine)

Dr. S. Suresh Babu M.D. (Ayu.)

(According to CCIM Syllabus, N. Delhi)

Complete in 4 Vols.

Kaumārabhṛtya

(Paediatrics in Āyurveda)

Dr. V.L.N. Sastry, Foreword by Dr. Premvati Tewari

A Text Book On Śalya Tantra

Dr. Rajneesh V. Giri

(According to BAMS syllabus approved

by C.C.I.M., N. Delhi)

Complete in 2 Vols.

Printed by: Charu Printers, Golghar Varanasi-1

*Dedicated to My
Reverend Father*

ŚRĪ RAMĀŚAṆKARA TEWĀRĪ

(23rd Feb. 1914 — 7th Feb. 1987, Vill. Amour, Dist. — Kanpur, U. P.)

Premvati Tewari

पूज्य पितृदेव

श्री रमाशंकर तिवारी

(जन्म - २३ फरवरी, १९१४, ग्राम - अमौर, जिला - कानपुर, उ. प्र.; निर्वाण ७ फरवरी १९८७)



की पुण्य स्मृति में
सादर समर्पित

प्रेमवती तिवारी

द्वितीय संस्करण के लिए दो शब्द

आयुर्वेदीय प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग के प्रथम भाग प्रसूतितंत्र एवं द्वितीय भाग स्त्रीरोग के प्रथम संस्करण का प्रकाशन क्रमशः बारह एवं आठ वर्ष पूर्व हुआ था। प्रथम एवं द्वितीय भाग के प्रकाशन के अन्तराल में पठनपाठन में प्राप्त अनुद्भूत परन्तु उपयोगी सन्दर्भों को यद्यपि द्वितीय भाग के परिशिष्ट पाँच में प्रथम भाग के उस शीर्षक तथा पृष्ठ संख्या को निर्दिष्ट करते हुए उद्धृत कर दिया गया था, जहाँ इन सन्दर्भों को वास्तव में लिखा जाना चाहिए था, परन्तु प्रथमभाग की मूल विषय वस्तु में इन सन्दर्भों का कोई संकेत न होने के कारण पाठक इस तथ्य से तब तक अनभिज्ञ ही रहता था जब तक कि वह द्वितीय भाग के इस अंश को नहीं पढ़ता था। पृष्ठों का यह व्यवधान सन्दर्भों की उपयोगिता को भी प्रभावित करता था। अध्ययन एवं मनन के इन आठ वर्षों में एकाध स्थानों में विषय का स्थानान्तरण या अभ्यास का पुनर्व्यवस्थापन उपयोगी प्रतीत हुआ। कतिपय अन्य अनुद्भूत सन्दर्भ मिले, कुछ विचारों में परिवर्तन या परिवर्धन हुआ, जिन्हें सुधी पाठकों तक पहुँचाने का लोभ संवरण नहीं कर सकी, अतः प्रस्तुत है यह किञ्चित् परिवर्तित, परिवर्धित एवं परिसंस्कृत द्वितीय संस्करण, इस आशा, आकांक्षा एवं विश्वास के साथ कि विद्वज्जन अपनी सकारात्मक आलोचनाओं एवं विचारों से लेखिका को निश्चित ही अवगत कराने की कृपा करेंगे।

२३ जून, १९९८

प्रेमवती तिवारी

भूमिका

(प्रथम संस्करण से)

TWO WORDS ABOUT SECOND EDITION

First part Prasūtitantra and second part Strīroga of Āyurvediya Prasūtitantra evam Strīroga were published respectively twelve and eight years back. In the intervening period of four years between publication of first and second part, few important but unquoted references coming to light were presented in Appendix V of Part II, indicating relevant heading and page no. of Part I, however the text of Part I did not contain any hint of this fact, naturally the reader remained ingorant about these, till he could read Appendix V of Part II. This difference of hundreds of pages between exact text and relevant reference minimised the utility of these references. Within the period of these eight years after publication of second part, in the process of teaching, learning and study it was felt that few topics or even chapters if rearranged will become more intelligible, Certain new references came to light, few ideas and explanations flashed in mind. As I could not refrain myself from conveying these references, ideas and explanations to learned readers, thus, this modified, slightly rearranged / changed and elaborated second edition is presented with the fond hope that their constructive criticism will make my path of learning clearer and easier.

23rd, June 1998

Premvati Tewari

प्रसूतिचक्र एवं स्त्रीरोग आयुर्वेद की आधुनिक शाखायें हैं, प्राचीन अष्टाङ्गविभाग में इनका उल्लेख नहीं है किन्तु अष्टाङ्ग में अन्यतम कौमारभृत्य का यदि विस्तरेषण किया जाय तो ये उसी में समहित दृष्टिगत होंगे। कुमार के आविर्भाव के पूर्व मातृ-गर्भाशय में १-१० मास की अवधि में उसका जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। यह सब कौमारभृत्य के ही अन्तर्गत आता है। गर्भाधान न हो तो कुमार का अस्तित्व कैसे होगा? और सम्पक् गर्भाधान के लिए स्त्री के यौन अङ्गों तथा बीज (रजस्) का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि इनमें कोई विकृति है तो उसका निराकरण करना भी आवश्यक होगा। श्वेत यदि उत्तम एवं स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें बीज-वर्जन निरर्थक ही सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रसूतिचक्र एवं स्त्रीरोग कौमारभृत्य का ही आधारभूत अङ्ग या उपङ्ग है।

प्राचीनकाल में आयुर्वेद के आठ अङ्ग निर्धारित हुए थे किन्तु आजकल इनकी संख्या दूनी हो गई है अतः अब आयुर्वेद षोडशाङ्ग हो गया है। प्राचीन अङ्गों में भूतविद्या अपने मौलिक अर्थ में अब अप्रचलित हो गया है तथा उनेक नये नये अङ्गों का विकास हुआ है जिनमें प्रसूतिचक्र एवं स्त्रीरोग भी हैं। कालक्रम से आवश्यकता के अनुरूप इन अङ्गों की संरचना होती गई। उदाहरण स्वरूप, मध्य कालीन तन्त्र की शाखा के रूप में 'रसशास्त्र' नामक एक नवीन एवं अद्भुत अङ्ग का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार द्रव्यों के गुणकर्म के अध्ययन के लिए 'द्रव्यगुण' नामक अङ्ग संघटित हुआ। १९वीं शती के द्वितीय चरण में जब भारत में आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा के लिए मेडिकल कालेज खुले तो उनमें अनेक अङ्गों की शिक्षा विस्तार से दी जाने लगी। इसके प्रभाव से आयुर्वेद में भी नवीन अङ्गों का विभाजन एवं विशदीकरण प्रारंभ हुआ। आयुर्वेद के विद्वान इस नये आलोचक से अपने घर को सजाने सर्वरसे में लग गये और आयुर्वेदीय ग्रन्थों में निहित सूत्रों, टीकाओं एवं संघर्षों को विषयक्रम से व्यवस्थित किया जाने लगा। १९१० ई० के आसपास जब निखिल भारतवर्षीय विद्यापीठ ने आयुर्वेदीय शिक्षा तथा परीक्षा का क्रम प्रवर्तित किया तो इसी विषयक्रम-शैली को अपनाया। आगे चल कर १९२५ ई० से जो नये आधुनिक कालेज खुले उनमें भी यही क्रम निर्धारित हुआ जो आज तक चला आ रहा है। इस प्रकार आयुर्वेदीय प्रसूतिचक्र एवं स्त्रीरोग अपने विकसित रूप में आधुनिक युग की देन है।

आर्तव को पुष्प और अपरस को फल कहा गया है। जिस प्रकार वनस्पति में पुष्प फल का पूर्वसूचक और बीजाणवक दोनों हैं उसी प्रकार स्त्री में आर्तव होता है।^१ किन्तु गर्भाधान के लिए रज और शुक्र का संयोग आवश्यक है जो मैथुन (स्त्रीपुं-समागम) द्वारा संपन्न होता है अतः मैथुन को गर्भ का कारण माना गया। चरक ने शेषवत् (कार्य से कारण के अनुमान में यह दृष्टान्त दिया है (च० सं० सू० ११/३९)। शुक्र और रज दोनों 'बीज' हैं तथा ऋतु, श्वेत, जल आदि की सम्पक् स्थिति से इसके द्वारा गर्भ की उत्पत्ति होती है।^२ सुश्रुतेक कृषि के इन चार भागों का प्रतिपालन चरक ने युक्ति के दृष्टान्तरूप में किया है तथा इसके बाद ही गर्भ का दृष्टान्त भी दिया है किन्तु भिन्न रूप में। वस्तुतः बीज के अतिरिक्त अन्य भाव सहकारी कारण के अन्तर्गत आते हैं जिनका सम्पक् योग फल की निष्पत्ति के लिए आवश्यक है। चरक ने पूर्ववत् अनुमान के दृष्टान्तरूप में बीज से फल की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। चक्रार्णीण ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है- 'बीजादिति सहकारिकारणान्तरयुक्तिरिति बोद्धव्यम्'। इन्द्रियस्थानोक्त पुष्प-फल के दृष्टान्त में भी इसका संकेत किया गया है।

युक्ति-प्रकरण में जो दृष्टान्त दिये हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अनेक कारणों के (सम्पक्) योग से कार्य

१. पुष्प और फल में यह कार्यकारण-भाव चरक ने युक्तिपूर्वक इन्द्रिय (इन्द्रिय स्थान, अ० २) में स्पष्ट किया है।

२. सुश्रुत ने इन चार भागों का स्पष्टतः निरूपण किया है (सु० सं० शा० २/३३)।

की उत्पत्ति होती है यह अर्थ त्रिसैषणीय प्रमाण प्रकरण तथा परादि गुणोक्त युक्ति के लक्षणों के सामञ्जस्य से निकलता है। इस प्रकार युक्ति में बहुकारण योग, सम्यक् योग तथा इनके लिए अपात्रत बुद्धि इन तीनों का भाव अन्तर्निहित है। इस प्रकार में गर्भसंभव का जो दृष्टान्त दिया है उसमें पञ्चमहाभूत तथा चेतना इन छः धातुओं के संगोपा का उल्लेख है। क्योंकि पुरुष षड्धात्वानामक है और बिना इन छः धातुओं के समुचित सन्निवेश के उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्पष्टतः यह तार्किक दृष्टि से गर्भोत्पत्ति का निरूपण है जब कि श्रुतिप्रमाण दृष्टान्त में प्रायः बाह्य सहकारी कारणों का निर्देश है।

चक्र ने बीज के अतिरिक्त, बीजभागा तथा बीजभागावयव का भी उल्लेख किया है जो उनके आनुवंशिकी संबंधी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि का परिचायक है।

विश्यों में शुक्रधातु का अस्तित्व है या नहीं इस पर पर्याप्त चर्चा हुई है और प्रस्तुत ग्रन्थ में भी विस्तार से इसका विवेचन किया गया है। यदि शरीर समधात्वानामक है तो उस दृष्टि से स्त्री तथा पुरुष के शरीर में भेद नहीं किया जा सकता। यह सर्वशरीरव्याप्त होकर अन्य धातुओं तथा ओज की प्रभावित करता है इसका एक अंश पुरुषों में व्यक्त होकर अपत्योत्पादन का कार्य करता है किन्तु उनमें भी यह व्यक्तता एवं तत्संबद्ध कार्य पुत्रावस्था में ही होते हैं। आदि (बाल्यावस्था) तथा अन्त (वृद्धावस्था) में यह अव्यक्त ही रहता है तथा सत्त्वगोत्पादन का कार्य भी नहीं करता। अतः स्पष्ट है कि जिस कतिपय आचार्यों ने प्रादुर्भूत शुक्र कहा है वह शुक्र का एक अंशमात्र है जो एक अवस्था विशेष में उपलब्ध होता है। किन्तु इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इसका मूल स्वरूप अव्यक्त है और इस रूप में स्त्री तथा पुरुष दोनों शरीरों में विद्यमान होता है। यह आश्चर्य की बात है कि परवर्ती आचार्यों तथा टीकाकारों ने व्यक्त शुक्र को ही आधार बना कर वितण्डा खड़ा किया।

पुरुष के उदाहरण को ही लें। आचार्यों ने पुष्पमुकुल का दृष्टान्त देकर यह समाधान का प्रयत्न किया है कि बाल्यावस्था में अव्यक्तता के कारण शुक्र की उपलब्धि नहीं होती न कि अभाव के कारण, किन्तु मेरे विचार से शुष्क पुष्प का भी दृष्टान्त दिया जाना चाहिए था जो वार्धक्य में शुक्रशेष के कारण अव्यक्तता का द्योतक होता तथा इस प्रकार मानवशरीर में आदि से अन्त तक शुक्र के अव्यक्त प्रवाह की धारा का निदर्शक बनता। अब इसी दृष्टान्त को सामने रख कर क्या कोई कह सकता है कि स्त्रीशरीररूपी पुष्प निर्निष्ठ है ?

प्राचीनतम उपलब्ध चरक संहिता में ऐसा कोई विभेदक वचन नहीं मिलता। धातुनिर्माण की प्रक्रिया जहाँ बतलाई है वहाँ सामान्य रूप से ही वर्णन किया गया है, स्त्री और पुरुष में कोई अन्तर नहीं दिखलाया गया (देखें चं० सं० २८/४, शां० ६/१० आदि), ऐसा प्रतीत होता है कि सुश्रुत के वचनों से इस संबंध में श्रान्ति का श्रीगणेश हुआ जिसमें परवर्ती ग्रन्थकारों ने और योगदान किया। इस कारण प्रबुद्ध टीकाकारों को भी प्राचीन मान्यता की रक्षा में परेशानी हुई। सुश्रुत के कथन 'एवं मासेन रजः शुक्रो भवति, स्त्रीणाञ्छार्तवम्' (सु० सं० सू० १४/४४) की व्याख्या में डल्हण को यह लिखना पड़ा कि यहाँ आर्तव शब्द शुक्र का बोधक है। शुक्र के समकक्ष आर्तव को खड़ा करने से यह कठिनाई प्रायः हुई। वस्तुतः आर्तव इससे पृथक् है और इसके अतिरिक्त है जिसका अपत्योत्पादन से संबंध है इसी कारण आर्तव को धातु न मान कर उपधातु की श्रेणी में रक्खा गया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि अपत्योत्पादन की दृष्टि से पुरुष तथा स्त्री में बीजभेद है। पुरुष में यह व्यक्तोभूत शुक्र है तथा स्त्री में आर्तव है किन्तु शुक्रधातु के जो वीर्यादि लक्षण हैं वह अव्यक्त रूप में दोनों में समानरूप से स्थित हैं जिसका प्रादुर्भाव (व्यक्तीभाव) वय विशेष में पुरुष में बीजार्थ होता है तथा नारी में रोमाञ्जी आदि के उद्गम में हेतुभूत होता है। इसी कारण सुश्रुत ने यहाँ (सु० सं० सू० १४/१८) 'शुक्र-प्रादुर्भाव' शब्द दिया है। इसी परीक्ष्य में सुश्रुत के उपर्युक्त वचन की भी व्याख्या करनी चाहिए जैसा डल्हण आदि टीकाकारों ने किया है।

प्रादुर्भूत शुक्र में स्थूलदृष्ट्या पुरुष तथा स्त्री के जननेन्द्रिय से जो साव होता है वह समान प्रतीत होता है। इसी को देखकर 'मुञ्चन्त्यै शुक्रमन्योन्म' आदि वचनों की कल्पना की गई किन्तु वास्तव में वह साव पुरुष एवं स्त्री दोनों में साधारण

रूप से उपस्थित कतिपय ग्रन्थियों से प्रादुर्भूत होता है जिसका अपत्योत्पादन से संबंध नहीं है। प्रजोत्पादनाथ जो शुक्र प्रादुर्भूत होता है वह वृषण से उत्पन्न होता है तथा उसमें बीजाणु (शुक्रकोटि) होते हैं जो गर्भजनन में समर्थ होते हैं। यह केवल पुरुष में होता है, इसके समकक्ष स्त्री में आर्तव (स्त्रीबीज) है। इस दृष्टि से दोनों में भेद है। स्त्रीशुक्र से गर्भोत्पादन की बात चक्र में कहीं नहीं आई है। वस्तुतः सुश्रुतोक्त 'अनस्थिस्ताव जायते' भी गर्भ का द्योतक नहीं है।

स्त्री में शुक्रधातु के अस्तित्व की पुष्टि चक्र के अनेक प्रसङ्गों से होती है जिनमें दो का उल्लेख पर्याप्त है—

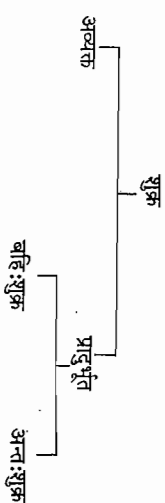
(क) शुक्रदोषों का वर्णन करते हुए चक्र में न केवल पुरुषगत प्रत्युत स्त्रीगत तथा अपत्यागत लक्षणों का भी वर्णन किया है। गर्भसाव आदि स्त्रीगत शुक्रदुष्टि के लक्षण हैं—'शुक्रं किं दुष्टं सापत्यं सदातं बाधते नरम्' (चं० सं० सू० २८/१८-१९), चक्राणां ने इसकी व्याख्या में लिखा है—'अत्रापत्यबाधा रोगिणस्त्रीबाधपरचनकत्वेन, दारबाधा तु स्वाधिर्भादिजनकत्वेन'।

(ख) इन लक्षणों में क्लैब्य और अहर्षण प्रमुख हैं जो पुरुष के साथ साथ स्त्री में भी होते हैं। चक्र ने नरषण्ड के साथ साथ नारीषण्ड का भी वर्णन किया है (चं० सं० शां० २/१७-१९), यहाँ भी बीजभागा की दृष्टि से क्लैब्य में अन्तर होगा किन्तु बल और हर्ष दोनों में समान हैं। हर्षण स्त्री-पुरुष का एक दूसरे के प्रति होता है कामवासना के क्रम में, किन्तु यही हर्ष स्त्री में अपत्य के प्रति वास्तव्य के कारण सत्य-प्रादुर्भाव का कारण बनता है। इसी दृष्टि से आचार्यों ने शुक्र एवं सत्य में समानता बतलाई है किन्तु यह प्रवृत्तिमूलक है, स्वरूपमूलक नहीं। स्वरूप में इतनी ही समानता है कि जिस प्रकार शुक्र अव्यक्त रूप से समस्त शरीर में व्याप्त होते हुए भी स्त्री के समगमन में प्रादुर्भूत होता है वैसे ही सत्य भी (बीजरूप में) सर्वदेहिश्रित होते हुए भी अपत्य के प्रति स्नेह से व्यक्त होता है (हर्षार्तवार्त... प्रसिच्यते-चं० सं० वि० २-४/४६-४९; सर्वार्त्वाच्चप्रवर्तते-सु० सं० नि० १०/१९-२३)।

वीर्य (धर्म, पराक्रम, शक्ति का समुच्चय) भी शुक्र का एक प्रमुख कर्म है। इसकी प्रमुखता के कारण ही वीर्य शुक्र का पर्याय बन गया है। वीर्य का अस्तित्व विश्यों में प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है। कहीं कहीं तो वह इसमें पुरुषों की भी नाक काटती है। वीर्या-शरत्ता के अनेक दृष्टान्त स्त्री-समाज में मिलते हैं। इसके अधिक्य के कारण स्त्रीवाचक 'दार' शब्द को युष्किङ्ग (उसमें भी बहुवचन) रक्खा गया (पुंभूम्निदाराः-अमरकोष २/६/६)।

सारांश यह कि तिल में तैल, दूध में घृत तथा इक्षु में रस जिस प्रकार समस्त (अव्यक्त रूप में) व्याप्त रहता है उसी प्रकार शुक्र बिना र्तिगभेद के समस्त शरीर में समान रूप से व्याप्त है। इस प्रकार सर्वदेहिश्रितव्य शुक्र का प्रथम लक्षण हुआ (सर्वदेहिश्रितव्य शुक्रलक्षणमुच्यते-सु० सं० नि० १०/९)। दूसरा लक्षण वीर्यादि कर्तृत्व है, यह भी सामान्य रूप से स्त्री-पुरुष दोनों में मिलता है। ये दोनों लक्षण अव्यक्त शुक्र के हैं। तीसरा लक्षण अपत्योत्पादकत्व प्रादुर्भूत शुक्र का लक्षण है जो केवल पुरुष में मिलता है। इस प्रकार 'सर्वदेहिश्रितव्ये सति वीर्यादिकर्तृत्वं शुक्रत्वम्' यह सामान्य लक्षण घटित हुआ। 'अपत्योत्पादकत्वं' विशिष्ट लक्षण हुआ।

आधुनिक काल के आचार्यों ने जो 'अन्तःशुक्र' तथा 'बाहिःशुक्र' संज्ञायें निर्धारित की हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अव्यक्त तथा व्यक्त ये प्राचीन संज्ञायें अर्थद्वयोन के लिए पर्याप्त समर्थ हैं। किन्तु यदि यह कहना ही है तो ये विभागा प्रादुर्भूत शुक्र के होंगे। इसे इस प्रकार रक्खा जा सकता है—



इस विषय पर विदुषी लेखिका ने सभी संभावनाओं पर विचार कर सभीचीन विरलेषण विचरण में प्रस्तुत किया है। 'योनि' शब्द 'यु' धातु से निष्पन्न है जो दो अर्थों में प्रयुक्त है—एक मिश्रण (एवं अभिमिश्रण) तथा दूसरा जुगुप्सा। इसके अनुसार 'योनि' का अर्थ होगा 'जहाँ' (शुक्र एवं रज का) मिश्रण हो। यह सदा नहीं होगा जब स्त्री-पुरुष मिलेंगे तभी होगा अतः अभिमिश्रण का अर्थ भी इसमें निहित है। अनेक तत्त्व परस्पर मिल कर पट की संरचना करते हैं अतः 'योनि' शब्द कारण का भी बोधक बना। स्त्री-पुरुष जननोद्देश्यों की स्वेच्छावाहिता से समाज में अनाचार फैलता है अतः ये पाप का मूल मानी गई हैं। इस अर्थ में 'योनि' में जुगुप्सा का भाव निहित है। इसी प्रकार पुरुष-शिरण के लिए एक शब्द 'कौपीन' का प्रयोग हुआ है। मूलतः 'कौपीन' शब्द पाप का बोधक है क्योंकि इससे मनुष्य कुएं में डूब जाने की स्थिति में आ जाता है। पाप का साधन होने के कारण शिरण भी 'कौपीन' कहलाया तथा परम्परा उसका आच्छादक वस्त्र भी कौपीन कहा जाने लगा।

गर्भाशय की स्थिति के विषय में भी संहिताओं में जो वचन आये हैं उनकी व्याख्या में मतभेद है तथा यह विवादास्पद बना हुआ है। कविराज गणनाथ सेन ने 'पितृपक्वाशयोर्मध्ये' के स्थान पर 'वसिष्ठपक्वाशयोर्मध्ये' यह पाठान्तर स्वीकृत कर इसका समाधान प्रस्तुत किया था। उनकी मान्यता थी कि संहिताओं की प्राचीनता तथा लिपिकारों के प्रमाद की संभावना को देखते हुए उनमें प्रतिसंस्कार अपेक्षित हैं। अतः जहाँ ऐसी कठिनाई हो वहाँ इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। डॉ० घाणेकर ने इसका प्रतिरोध किया, उनका कहना था कि जो लिखा है विलकुल सही है, हमें केवल उसकी सही व्याख्या करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने अपना मत भी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत ग्रन्थ की लेखिका ने भी इस संबन्ध में अपना एक मौलिक विचार दिया है जिस पर और विवेचन की आवश्यकता है। 'आवर्ता' में 'आवर्त' शब्द आवृत्ति (आवरण) तथा जलावर्तवत् वृत्ताकार रचना दोनों का बोधक हो सकता है। शंखनाभि से द्वितीय अर्ध का संकेत मिलता है।

श्लुचक्र की विभिन्न अवस्थाओं में दोषों की उत्पत्ति पर भी विचार किया गया है और अनेक विद्वानों ने इस पर अपने मत व्यक्त किये हैं। इस संबन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि रज का मौलिक स्वरूप आग्नेय है अतः इसकी प्रवृत्ति या सक्रियता के काल में पित्त की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। रजःस्त्राव की प्रक्रिया में यद्यपि बहिर्मुखी गति में अपना वायु का योग है तथापि रक्त तो आग्नेय ही है जो वैश्विक कहा जा सकता है। इसी कारण इसकी अतिप्रवृत्ति में रक्तपित्तवत् उपचार करने का विधान है। श्लुचकाल में भी स्त्री-पुरुष समागम के पूर्व स्त्री को माष-तैल आदि पित्तकर आहार करने का उपदेश है। यह दूसरी बात है कि कफ इसको देर तक स्थिर रखने का कार्य करता हो जैसे दीपक में वृत्ति-ज्वाला को स्थिर रखने का कार्य तैल करता है। माष और तैल पित्त के साथ साथ कफ को भी बढ़ाने वाले द्रव्य हैं। अष्टांगसंग्रहोक्त श्लोक 'आर्तव तिष्ठति चिरं' का भी यही अभिप्राय है।

'गर्भावक्रान्ति' शब्द की व्याख्या चक्रपाणि ने अत्यन्त सरल ढंग से की है—'गर्भस्यावक्रान्तिः मेलकः, गर्भोत्पत्तिरिति यावत्।' किन्तु इसमें दार्शनिक रहस्य छिपा है। उत्क्रान्ति एवं 'अवक्रान्ति' जीव के शरीर से संबन्ध के द्योतक शब्द हैं। 'उत्क्रान्ति' का अर्थ है 'शरीर से (निकल कर) ऊपर चले जाना और 'अवक्रान्ति' का अर्थ है (ऊपर से उतर कर) शरीर में आ जाना। ब्रह्मसूत्र (२/३/१९) के सूत्र 'उत्क्रान्तियात्प्रातर्नाम' के भाष्य में इसका विवरण विवेचन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद् (४/४/२) में 'उत्क्रमण' के लिए 'निक्रमण' शब्द भी दिया है—'तेन प्रद्योतनैष आत्मा निक्रामति तनुक्रान्तं प्रणोऽनुक्रामति...', उपर्युक्त ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, 'उत्क्रमणं हि मरणे निवृत्तम्' अर्थात् स्पष्ट शब्दों में उत्क्रमण का अर्थ मरण है। इस प्रकार अवक्रमण का अर्थ जीवन होगा। शुक्रशोणितसंयोग में जब जीव अवक्रान्त होता है (जीवोऽवक्रामति) तभी उसमें चैतन्याधान होता है तथा उसकी गर्भसंज्ञा होती है। वस्तुतः उत्क्रान्ति

१. कृपयतनमर्हति कौपीनं पापम्, तत्प्राप्तमन्त्रात् तद्गोप्यत्वाद् वा पुण्यलिङ्गमपि: तत्संबन्धात्तत्तच्छादनमपि-सिद्धान्तकौमुदी (शालोन्कापीने अधुष्टकावयो: ५/३/२० की वृत्ति। और देखें अमरकोश-अकर्मगुहो कौपीनम् ३/३/१२२)।

और अवक्रान्ति ऊपर और नीचे दिशा के बोधक शब्द नहीं हैं अपितु चैतन्य की स्थिति के द्योतक हैं। जब परिच्छिन्न देह से उसका संबन्ध टूटता है तब उसके विधुल का स्फुटन होता है और इसके विपरीत जब देह की सीमा में बँधता है तो वह अपने मूल स्वरूप से नीचे उतरता है। इसीको संकोच और प्रसार भी कहते हैं। अवक्रान्ति चैतन्य का संकोच है और उत्क्रान्ति उसका प्रसार। किन्तु काश्यप ने इस पारिभाषिकता का ध्यान न रख कर पूर्वशरीर से आने की अवक्रमण और परशरीर में प्रवेश को उत्क्रमण कहा (पूर्वशरीराव्यावक्रामति, परशरीर्योपक्रामति)।

द्वन्द्व प्राणों में प्रथम तीन हैं—'अग्निः सोमो वायुः'। गर्भ में प्राण का सञ्चरण कर उसकी वृद्धि इनके द्वारा होती है। नाभि में अग्नि का स्थान कहा गया है। तत्र में भी वहाँ मणिपूर चक्र की स्थिति बताई गई है जो अग्नि का केन्द्र है। माता के आहार रस से प्राप्त पोषण सोम है। उसका कार्य-शरीर में सञ्चरण तथा विभिन्न अवयवों को विकसित करने है। माता है। सुश्रुतोक्त सन्दर्भों को ध्यान से देखने पर यही स्थिति स्पष्ट होती है।

'व्यञ्जनानि' और 'व्यक्तीभावः' (च० सं० शा० ४/१४) ये दोनों शब्द यौन भावों में संबन्ध रखते हैं। 'व्यञ्जन' शब्द करणवाची है अर्थात् वह साधन जिससे यौन प्रसफुटन ज्ञात हो। इसमें दाढी, मूँछ आदि आते हैं। रोग के संदर्भ में इसी स्थिति के द्योतन के अर्थ में 'व्यञ्जन' लक्षणा का पर्याय है—वह लक्षण जिससे व्यक्त व्याधि का ज्ञान हो। 'व्यक्तीभाव' में अभ्युत्पन्नत्व अर्थ में 'व्य' प्रत्यय है जिसका अर्थ है उन पदार्थों का व्यक्त होना जो पहले अव्यक्त थे। जब यह प्रस्र उठा कि बालकों में शुरू होता है या नहीं तो यह कहा गया कि उस काल में वह अव्यक्त होता है जो आगे चल कर व्यक्त हो जाता है। इसी आधार पर दीकाकारों ने इसका अर्थ 'शुक्राजसोरादिमर्गः' किया है।

'दौहद' शब्द पर भी विचार करें। यह गर्भिणी की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कालक्रम से इस शब्द में किञ्चित् रूपान्तर होता गया है। चरक ने इसके लिए 'दौहद' शब्द का प्रयोग किया है जो दो हृदय (एक माता का और दूसरा गर्भ का) के अर्थ पर आधारित है। सुश्रुत में 'दौहद' (या 'दौहद') शब्द आया है यद्यपि इसका आधार उपर्युक्त ही बतलाया गया है। आगे चल कर इसका रूप 'दौहद' हो गया जो अमरकोष में मिलता है। इस प्रकार यह शब्द हैहृदय-दौहद-दौहद इस क्रम से रूपान्तरित हुआ है किन्तु मूल भाव चरकोक्त शब्द में सुरक्षित है। चतुर्थ मास में हृदय के व्यक्त होने के कारण इस मास तथा अग्रिम मास में हृद्य अत्र का विधान गर्भिणी के लिए किया गया है।

गर्भिणी-चर्या के प्रसंग में पुराणों में वर्णित ४९ मरुतों की उत्पत्ति का आख्यान ध्यान देने योग्य है। पद्मपुराण में यह कथनक इस प्रकार है—दिति ने अपने पति काश्यप से ऐसे पुत्र की याचना की जो इंद्र का वध कर सकें। काश्यप ने ऐसा ही किया। दिति गर्भवती हुई, काश्यप ने उसे सावधानी से नियत समय तक गर्भिणीचर्या का पालन करने का उपदेश किया। इंद्र को जब इसका पता चला तो वह प्रच्छन्न कुटिल भाव से दिति के पास इस ताक में लगे रहे कि उसकी चर्या में कोई व्यवधान हो तो मैं गर्भ को नष्ट कर दूँ। नियत अवधि के केवल तीन दिन शेष रहे तो दिति असवधानी से त्रिना पेर धोये और बालों को ठीक किये सो गई। इस बीच अवसर पाकर इंद्र गर्भाशय में प्रविष्ट हो गये और गर्भ को वज्र से सात छण्डों में काट दिया। गर्भ रेतने लगे मना करने पर भी चुप नहीं हुए तो पुनः प्रत्येक छण्ड के सात टुकड़े कर दिये। इस प्रकार ४९ मरुत् हुये। (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अ० ७)। इस कथनक से गर्भिणीचर्या का पूर्णतः पालन करने का संकेत मिलता है।

ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय की शिक्षा अर्धशरीर से अधिक काल से प्रचलित होने पर भी कोई ऐसा ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध नहीं था जो समस्त विषय का शास्त्रीय स्वरूप प्रस्तुत करने के साथ साथ इसका एक समीचीन एवं व्यावहारिक रूप स्पष्ट कर सके। श्रोत्रेसर डॉ० (कु०) प्रेमवती तिवारी की रचना से इस अपभाव की पूर्ति हुई है बल्कि यह कहना अधिक संगत होगा कि आयुर्वेदीय प्रसूतान्न एवं स्त्रीरोग का यह सर्वप्रथम आधार ग्रन्थ है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में विदुषी लेखिका ने अपने दीर्घकालीन अध्ययन एवं शोध के अनुभवों का पूरा उपयोग किया है।

उन्हीने प्रत्येक पक्ष पर आयुर्वेद की सभी उपलब्ध संहिताओं, संग्रहग्रन्थों तथा टीकाओं से उपयुक्त सामग्री का संकलन कर उसे युक्तिपूर्वक व्यवस्थित किया है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदोत्तर वाङ्मय में भी विकीर्ण प्रासंगिक वचनों की भी उद्धृत किया है। इस प्रकार यह अपने विषय का एक महाकोश बना गया है। ग्रन्थ की वस्तुयोजना भी युक्तिसंगत है। अनेक विचारणीय विषयों पर विमर्श भी विस्तार से दिया है जिसमें विषय का विश्लेषण कर विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कर वैज्ञानिक आधार पर अपना विचार प्रस्तुत किया गया है। अनेक संदर्भों में जो विचार दिये गये हैं उनमें गिताल मौलिकता है जो लेखिका के सूक्ष्मानीक्षण का संकेत देती है।

इस प्रकार यह ग्रन्थ न केवल छात्रों अपितु अध्यापकों तथा शोधकर्ताओं के लिए अत्युपयोगी एवं मार्गदर्शक सिद्ध होगा। साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद होने से इससे देश-विदेश के अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे।

अपने विषय के प्रति ऐसी निष्ठापूर्ण साधना एवं उत्तम प्रस्तुति के लिए मैं प्रो० प्रेमवती तिवारी जी को साधुवाद देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि चिकित्सातत्वीय कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वह कुछ क्षण सरस्वती-साधना में लगाती रहेंगी जिससे उनके द्वारा आयुर्वेद-वाङ्मय की निरन्तर श्रीविद्भि होती रहे।

गुरुधाम कालोनी,

१० फरवरी १९८६

प्रियव्रत शर्मा

आमुख

(प्रथम संस्करण से)

काल के कुचक्र ने विश्व की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद की प्रगति में एक व्यवधान उत्पन्न किया, जो व्यवधान अनेकों सामाजिक, नैतिक एवं वैधानिक कारणों से प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग में अपेक्षकृत अधिक अनुभूत हुआ।

आयुर्वेद के प्रति विश्व के वैज्ञानिकों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अभिरुचि एवं देश के वर्तमान-काल में किञ्चित् परिवर्तित या प्रगतिशील आयुर्वेद की प्रशिक्षण परम्परा में एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न सामने आता है, "क्या आयुर्वेदिक संहिताओं में वर्णित विषय के आधार पर प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग को क्रियात्मक स्वरूप दिया जा सकता है" ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यकता है, वर्णित विषय के समष्टि स्वरूप के ज्ञान की, उसके विश्लेषण, परिसंस्करण, परिमार्जन एवं परिवर्धन की।

प्रयोजन—

आयुर्वेदीय संहिताओं में वर्णित प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग सम्बन्धित विषय के समष्टिस्वरूप के ज्ञानार्थ संहिताओं का आद्योपात्त अवलोकन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विषय किसी एक स्थान या अध्याय में न होकर विभिन्न स्थानों या अध्यायों में एवं कभी कभी अन्य विषय के साथ भी वर्णित है। विशेषतः अधुना प्रचलित शीर्षकों पर आधारित अंग-विशेष के ज्ञान के लिए सम्पूर्ण संहिता अथवा संहिताओं का अवलोकन करने पर पाठक के मूल विषय से दूर हट जाने का भय एवं समय का अपव्यय होता है।

प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द अनेकार्थावची होते हैं। यह सम्भव है कि विभिन्न लेखक शब्दों के आधार पर विषय का स्पष्टीकरण पृथक् पृथक् विधि से करें, अतः यह आवश्यक होता है कि ग्रन्थों के मौलिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया जाय। इसी विचार से प्रेरित हो प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गयी है, जिसका मूल उद्देश्य प्रचलित आयुर्वेदीय संहिताओं में वर्णित प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग सम्बन्धित विषयों का अधुना प्रचलित शीर्षकों के अन्तर्गत व्यवस्थित करना है, जिससे विषय का क्रमबद्ध एवं विशद् ज्ञान हो सके।

आयुर्वेद के अष्टाङ्गों में प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग—

सम्प्रति उपलब्ध एवं प्रचलित प्राचीनतम संहिता चरक के अनुसार भगद्वज मुनि को भगवान् इन्द्र ने त्रिसूत्र या त्रिकन्ध आयुर्वेद का उपदेश किया। पुनश्च आयुर्वेद के अङ्गों के संदर्भ में इसके आठ अङ्गों का नामोल्लेख तो है, परन्तु प्रत्येक अङ्ग के क्षेत्र में आने वाले विषय का स्पष्टीकरण नहीं है। महर्षि सुश्रुत एवं परवर्ती आचार्यों के मतानुसार आयुर्वेद का

१. हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थगुरुरपयणम्। त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुद्धये यं पिलाभः ॥ २४॥
सोऽन्तत्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं ॥ २५॥ (च० सं० सू० १)

२.। कतिकानि चास्याङ्गानि ? ॥ २० ॥

तस्यायुर्वेदस्याङ्गान्यष्टौ, ॥ २८ ॥ (च० सं० सू० ३०/२० व २८)

पृथ्वी में अवतरण उसके अष्टाङ्ग स्वरूप में ही हुआ^१। महर्षि सुश्रुत ने विभिन्न आठ अङ्गों में सन्निहित विषयों का स्पष्टरूप वर्णन किया है, जो पुनः अष्टाङ्गसंग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय आदि ग्रन्थों में दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका सम्भाव्य कारण इन आचार्यों द्वारा अति संक्षिप्त वर्णन का अपाह हो सकता है। महर्षि कारश्य ने चरक के समान ही केवल अष्टाङ्गों का नामोल्लेख तथा महर्षि हारीत ने विभिन्न अङ्गों में समाविष्ट विषय का वर्णन दिया है। ऐसा आभास होता है कि चरक का काल आयुर्वेद के अष्टाङ्ग विभाजन का प्रारम्भिक काल था। सुश्रुत के काल में इस प्रक्रिया में परिपक्वता आई, विभिन्न अङ्गों के विशेषज्ञ हुए, जिन्होंने सम्भवतः अपनी-अपनी संहितायें भी लिखी हों। यह परम्परा विशिष्ट सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्थिर न हो सकी और पुनः सम्पूर्ण आयुर्वेद का समस्त रूप में ही अध्ययन किया जाने लगा।

पुस्तक से सम्बन्धित विषय अष्टाङ्गों में कौमारपुत्र्य के अन्तर्गत आता है। इस विशिष्ट अङ्ग के लिए महर्षि चरक ने कौमारपुत्र्यक^२, सुश्रुत ने कौमारपुत्र्य या कुमारतन्त्र^३, कारश्य^४ ने कौमारपुत्र्य एवं अष्टाङ्गसंग्रह^५, अष्टाङ्गहृदय^६ तथा हारीत ने बालचिकित्सा शब्द का प्रयोग किया है।

जैसा पहले कहा गया, महर्षि सुश्रुत तथा हारीत के अतिरिक्त किसी भी अन्य आचार्य ने इन विशिष्ट अङ्गों में समाविष्ट होने वाले विषय का वर्णन नहीं दिया। टीकाकार चक्रपाणि के मत से कुमार के भरण से सम्बन्धित विषय कौमारपुत्र्य के अन्तर्गत आता है^७। भरण शब्द के अनेकों अर्थों में 'प्राप्त करना', 'दोना' या 'वहन करना' (गर्भाशय स्थित गर्भ को), 'जन्म देना', 'रक्षा करना', 'आश्रय या अवलम्ब देना' तथा 'योषित करना' आदि का शब्दकोषों में उल्लेख है^८। इसके अनुसार कुमार या शिशु को प्राप्त करने के उपायों से लेकर उसे वहन करने, जन्म देने, रक्षा करने, अवलम्ब देने तथा योषित करने से सम्बन्धित विषय का वर्णन कौमारपुत्र्य के अन्तर्गत आता है। कुमार के प्राप्त करने से सम्बन्धित विषय के अन्तर्गत स्त्री-शरीर-रचना एवं क्रिया तथा गर्भावक्रान्ति के साथ-साथ समस्त आर्तव तथा योनिदोषों का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट लिख दिया है कि आर्तव या योनि के दूषित होने से गर्भाधान

१. सु० सं० सू० १/६; अ० सं० सू० १/१०, ११; एवं का० सं० वि० २/१०।

२. तस्यायुर्वेदस्याङ्गान्यष्टौ, तद्वशा कायचिकित्सा, शालाक्यं, शल्यागर्हर्तृकं विषयवैरोधिकप्रथमं, भूतविद्या, कौमारपुत्र्यकं, रसायनं, वाजीकरणमिति ॥ (च० सं० सू० ३०/२८)

३. (अ) तद्वशा-शाल्यं, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूतविद्या कौमारपुत्र्यम्, अमादतन्त्रं, रसायनतन्त्रं वाजीकरणतन्त्रमिति ॥

(आ) सु० सं० सू० ३/३७। (सु० सं० सू० १/७)

४. इति अष्टाङ्गः; तस्य कौमारपुत्र्यं कायचिकित्सा शल्यागर्हर्तृकं शालाक्यं विषयतन्त्रं भूततन्त्रमादतन्त्रं रसायनतन्त्रमिति ॥ (का० सं० वि० २/१०)

५. कायबालाग्रहोष्वाङ्गशाल्यदंष्ट्राजरावृधेः ॥ १० ॥ (अ० सं० सू० १/१०)

६. कायबालाग्रहोष्वाङ्गशाल्यदंष्ट्राजरावृधम् ॥ ५ ॥ (अ० ह० सू० १/५)

७. शल्यशालाक्यकायाश्च तथा बालचिकित्सम् ॥ अमादं विषयतन्त्रं भूतविद्या रसायनम् ॥ वाजीकरणमेवेति चिकित्सा चाष्टधा स्मृता ॥ (हो० सं० प्र० स्थान २/५)

८. कुमारस्य भरणमधिकृत्य कृतं कौमारपुत्र्यं ॥ (च० सं० सू० ३०/२८ को चक्र० टीका)

९. 'संस्कृत-ईंग्लिश शब्दकोष' सर मोनियर मोनियर विलियम विरचित, पृ० ७४७ एवं 'संस्कृत-ईंग्लिश शब्दकोष' वामन शिवराम आटे विरचित, पृष्ठ ४००।

नहीं होता^९ अर्थात् गर्भ-प्राप्ति के लिए इन व्याधियों एवं उनकी चिकित्सा का ज्ञान आवश्यक है।

महर्षि सुश्रुत ने अङ्गों के संक्षिप्त लक्षणों के वर्णन में कौमारपुत्र्य के समन्वय में लिखा है कि कौमारपुत्र्य आयुर्वेद का वह अङ्ग है जिसके अन्तर्गत कुमार के भरण, धात्री, क्षीरदोष एवं उनके संशोधन के उपाय, द्रष्टृ सत्य एवं ग्रहों से उत्पन्न होने वाली व्याधियों तथा उनके शपन के उपायों का वर्णन है^{१०}। पुनश्च उदरतन्त्र के अध्यायों का निर्देश करते हुए लिखा है कि नवग्रहों की आकृति का ज्ञान, स्कन्ध का निषेध (स्कन्धग्रह प्रतिषेध) अपस्मार (स्कन्धग्रहप्रसार), शकुनि, रेवती, पूतना, अन्धा (अन्धपूतना), मण्डिका (मुखमण्डिका), शीतपूतना तथा नैगमेध की चिकित्सा (विभिन्न ग्रहप्रतिषेधाध्याय) एवं ग्रहोत्सर्ग के ही साथ योनिव्यापद् (योनिव्यापद्-प्रतिषेध) का वर्णन (२७ वें से ३८ वें अध्याय तक) कौमारतन्त्र है। इसके अतिरिक्त, शरीरस्थान में भी वर्णित विषय कौमारतन्त्र के अन्तर्गत आता है^{११}। टीकाकार डल्हन ने स्पष्टीकरण दिया है कि राज-शुद्धि एवं गर्भावक्रान्ति (शरीरस्थान अध्याय २ एवं ३) आदि विषय भी कौमारतन्त्रागत ही आते हैं^{१२}। चूँकि शरीरस्थान के ही दशम् अध्याय में गर्भिणी, गर्भस्राव, गर्भपात, सामान्य प्रसव, सुतिका-परिचर्या के ही साथ नवजात शिशु-परिचर्या, धात्री, स्तन्य तथा बालक की कतिपय व्याधियों का भी वर्णन है, अतः इस अध्याय के सम्पूर्ण विषय को कौमारपुत्र्य में अन्तर्भूत कर सकते हैं, जिसका स्पष्ट निर्देश चक्रपाणि ने अपनी टीका में दिया^{१३} है। योनिव्यापदप्रतिषेध नामक अध्याय के प्रारम्भ में टीकाकार डल्हन ने लिखा है कि कुमार-जन्मविकार में कारणभूत होने से योनिव्यापद् की चिकित्सा के लिए इस अध्याय की रचना की गई है^{१४}। इसी अध्याय में अन्त में 'इति कौमारपुत्र्यतन्त्रम्' का उल्लेख होने से योनिव्यापद् का कौमारपुत्र्य में समावेश और भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 'भरण' शब्द की व्याख्या एवं सुश्रुतसंहिता के उपर्युक्त वर्णन के आधार पर बालक से सम्बन्धित सभी विषयों के साथ ही प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग सम्बन्धी विषय भी कौमारपुत्र्य के क्षेत्र में आ जाते हैं। मूढगर्भ की चिकित्सा शल्य-विशेषज्ञ ही करते थे, अतः इसका समावेश शल्यतन्त्र के अन्तर्गत किया गया है^{१५}।

१. (अ) आर्तवमपि शिथिलैः शोणितचतुर्धैः पृथग्दृष्टैः समस्तैश्चोपसृष्टमनोजं भवति ॥ (सु० सं० शा० २/५) आर्तवमपि शुक्रबद्धैर्धैरुपसृष्टमनोजमेव ॥ (अ० सं० शा० १/२५)

वातादि कुणप्रश्लिष्टपूषक्षेणमलाह्वयम् ॥ बीजासमर्थं रेतोसं ॥ (अ० ह० शा० १/१०)

(आ) न शुक्रं धारयत्येभिर्धातैर्व्योनिरुपद्रुता ॥ तस्माद्गर्भं न गृह्णाति स्त्री ॥ (च० सं० वि० ३०/३८) इति योनिगदा नारी येः शुक्लं न प्रतीच्छति ॥

ततो गर्भं न गृह्णाति ॥ (अ० सं० उ० ३८/५३ एवं अ० ह० उ० ३३/५२ शुक्लं के स्थान में शुक्रं)

२. कौमारपुत्र्यं नाम कुमारभरणधारीक्षीरदोषसंशोधनार्थं द्रष्टृस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपग्रहनाथम् ॥

(सु० सं० सू० १/८(५))

३. नवग्रहकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेधम् ॥ अपस्मारशकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक् ॥

पूतनायास्तथाऽअन्धाः शीतपूतनामण्डिका ॥ नैगमेधचिकित्सा च ग्रहोत्सर्गः सयोनिजा ॥

कुमारतन्त्रभिन्नेतच्छरीरेषु च कीर्तितम् ॥ (सु० सं० सू० ३/३५-३७)

४. शरीरेषु च कीर्तितमिति ॥ किं तच्छरीरेषूके ? तद्वशा-रज-शुद्धिः गर्भावक्रान्तिरित्यादि ॥

(सु० सं० सू० ३/३७ को डल्हन टीका)

५. शरीरेषु च कीर्तितमिति कुमारतन्त्राभिधेयं गर्भावक्रान्ति-प्रतिसमासविधि-जातकर्मादि बहु शरीरस्थाने कीर्तितम् ॥

(सु० सं० सू० ३/३७ को चक्र० टीका)

६. कुमारजन्मविकारकाणामात्रं योनिव्यापिचिकित्सार्थं ॥ (सु० सं० उ० ३८/१ को डल्हन टीका)

७. तत्र शल्यं नाम नखपूतनावदुष्टग्रहणान्तर्गमंशाल्योद्धरणार्थं ॥ (सु० सं० सू० १/८(१))

टीकाकार इन्द्र^१ एवं अरुणदत्त ने सम्भवतः मूल लेखक द्वारा 'बाल' शब्द के प्रयोग के कारण इस अङ्ग को बालकों से सम्बन्धित चिकित्सा में सीमित कर दिया है। टीकाकार अरुणदत्त ने स्पष्ट लिखा है कि बालक के देह, धातु एवं बल के असम्पूर्ण होने, वय के अप्रकट होने तथा अवस्था के प्रभाव के कारण उससे सम्बन्धित चिकित्सा का अङ्ग पृथक् निर्दिष्ट है तथा बालकों की व्याधियों के लिए किए गए प्रयत्न तथा औषधियाँ, धात्री-दुग्ध-लक्षण तथा दुग्धजन्य व्याधियों आदि श्रमन के उपायों का निर्देश भी इसी में है^२। ये दोनों ही टीकाकार प्रसूतिज्ञ एवं स्त्रीरोग से सम्बन्धित आयुर्वेद के अङ्ग के प्रति मौन हैं।

महर्षि हारीत ने बालचिकित्सा शब्द देते हुए गर्भोपक्रमविज्ञान, सुतिकोपक्रम तथा बालकों के रोगशमन सम्बन्धित विषय को बालचिकित्सा का विषय माना है^३। गर्भोपक्रम के अन्तर्गत समस्त स्त्रीरोग समाविष्ट हो जाते हैं, जो पहले कहा जा चुका है।

प्राचीनकाल में आयुर्वेदीय वाङ्मय का अधिकांश सूत्रन राजतन्त्र में ही हुआ, जहाँ राजा के उत्तराधिकारी के रूप में कुमार को उत्पत्ति, उसका पालन तथा पोषण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अर्तव्यपाद या योनिव्यापद गर्भाधानबाधक होते प्रसव में कठिनाई होने से बालक को विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसी भाँति सूतिका की भी अवस्था या व्यवस्था बालक के पालन-पोषण को प्रभावित करती है, अर्थात् सम्पूर्णङ्ग, स्वस्थ एवं सुन्दर कुमार की प्राप्ति के उपायों के लिए समस्त स्त्रीरोगों का चिकित्सा सहित ज्ञान, स्त्री-शरीर का रज एवं ऋतुचक्र सहित ज्ञान, गर्भावक्रान्ति, गर्भिणी, प्रजायिनी तथा सूतिका आदि सम्बन्धी विषय का सम्पूर्ण ज्ञान अत्यावश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में कुमार का अधिक महत्त्व होने के कारण उसे ही आधार या अक्ष मानकर इस अङ्ग को कौमारपुत्र्य का ही अङ्ग माना गया है। यह तथ्य काश्यप द्वारा वर्णित बालक की 'गर्भ, बाल एवं कुमार'^४ इन तीन संज्ञाओं में आयु के विभाजन से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि गर्भावस्था का बालक गर्भिणी द्वारा ही सेवित आहार से पोषित होता है अतः गर्भिणी-परिचर्या बालक के लिए अत्यावश्यक है।

समाज की वर्तमान स्थिति में स्त्री एवं बालक दोनों का ही स्वतन्त्र महत्त्व होने, चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र के अत्यधिक विस्तृत हो जाने तथा विशेषज्ञों द्वारा सीमित क्षेत्र ही चिकित्सित होने के कारण स्त्री तथा बालक दोनों ही अलग अलग विशेषज्ञों के क्षेत्र के विषय माने जाते हैं। सम्भवतः इसी विचारधारा के आधार पर आचार्य गणनाथ सेन जी ने प्रसूति-तन्त्र को कौमारपुत्र्य से पृथक् विशिष्टता, परन्तु स्त्रीरोग को कौमारपुत्र्य का ही अङ्ग माना है; परन्तु जब तक आयुर्वेद के अङ्गों की संख्या आठ में ही सीमित है प्रसूतिज्ञ, स्त्रीरोग एवं बालचिकित्सा सम्बन्धी समस्त विषय को कौमारपुत्र्य के ही अन्तर्गत मानना युक्तिसंगत होगा।

सङ्कलन में प्रयुक्त ग्रन्थों में प्रसूतिज्ञ एवं स्त्रीरोग सम्बन्धी विषय -

- प्रसूतिज्ञ एवं स्त्रीरोग सम्बन्धी विषय-वस्तु कौं दृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि महर्षि चरक ने स्त्री-श्रोणि की अभिर्या, स्त्री-शरीर-क्रिया (रजःस्राव आदि); गर्भ एवं गर्भावधान, गर्भावक्रान्ति, गर्भिणी-लक्षण, गर्भिणी-परिचर्या, १. बालस्य विशेषवक्तव्यात् पृथक्करणम् ॥ (अ० सं० सू० १/१० की इन्द्र टीका)
२. बालदेहेऽसम्पूर्णवतुल्यारुद्रकृदव्यवस्थाप्रभावात् तच्चिकित्साङ्गपृथक्निर्दिष्टम् । तथा बालोपाधिकभेषजं धात्रौदुधलक्षणं दुग्धोद्वव्याधिप्रशमादिनिर्देशाच्च ॥ (अ० ह० सू० १/५ व ६ की अरण्य टीका)
३. गर्भोपक्रमविज्ञानं सुतिकोपक्रमसंस्था । बालानां रोगशमनं क्रिया बालचिकित्सितम् ॥ (ह० सं० प्र० स्थानं २/१७)
४. गर्भावकालकुमारव्यतिरेकत् विविधं वयः ॥ (का० सं० खि० स्थानं ३/७२)
५. एवञ्च सर्वथा कौमारपुत्र्यात् प्रशोब प्रसूतिज्ञं मन्यन्म । स्त्रीरोगान्नु केचित् कौमारपुत्र्यान्तर्गता एव,। (प्रत्यक्षशरीर के उपाध्याय का "आयुर्वेदस्य प्राचीन गौरववर्धनं द्वितीय पाद" पृष्ठ ३६)

गर्भिणी को होने वाली व्याधियों के चिकित्सा-सिद्धान्त, गर्भिणी-उदवर्त, गर्भस्राव, उपविष्टक, उग्रशुष्क, भूतहत-गर्भ आदि गर्भ विकार, विकृत गर्भोत्पत्ति, सूतिकागण, सामान्य प्रसव, सूतिका, रज्जुगण, अमृगद तथा योनिव्यापद आदि विभिन्न स्त्री-रोगों के ही साथ नवजात शिशु-परिचर्या, असम्यक् परिचर्याजन्य व्याधियाँ, धात्री एवं सन्त्यदोषों आदि का विस्तृत वर्णन दिया है।

सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रन्थ है, स्वाभाविक ही है कि इस संहिता में शल्य-सामान्यी विषयों यथा स्त्री-शरीर-रचना तथा मूढगर्भ आदि का वर्णन (जो कि चरकसंहिता में नहीं) दिया गया है। शल्यचिकित्सक होने के कारण ही महर्षि सुश्रुत चिकित्सिकीय आचार-शास्त्र के विषय में भी सचेत थे एवं उन्होंने मूढगर्भा की चिकित्सा के पूर्व अधिपति की आज्ञा लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्मुख विषयों के अतिरिक्त महर्षि सुश्रुत ने चरक-संहिता में वर्णित विषय को देते हुए कुछ का अनुल्लेख एवं कुछ विषयों का समावेश किया है। वर्णन निम्नाङ्कित है।

सुश्रुत संहिता में वर्णित परन्तु चरक संहिता में अवर्णित विषय -

१. स्त्री-शरीर के रचानामक घटकों यथा पेथी, आर्तवहस्तोत्स आदि का विस्तृत वर्णन एवं शरीर के अङ्गप्रत्यङ्गों की उत्पत्ति के घटक।
२. स्त्रीशुक्र, रजोदर्शन के पूर्व बाला के शारीरिक परिवर्तन, रस से एक मास में शुक्र के साथ ही आर्तव की उत्पत्ति, रज का निर्माण एवं कार्य, रजोदर्शन एवं रजोनिवृत्ति की आयु, गर्भाशयिक धमनियों में सम्पूर्ण मास रक्त का एकत्रोत्सर्ग, रजःस्वला के द्वारा अञ्जादि के प्रयोग से हानि, ऋतुस्राव के समय संभोग का परिणाम, ऋतुस्राव के चौथे दिन पति के दर्शन का प्रभाव एवं ऋतुकाल।
३. गर्भोत्पत्ति में महाभूतों के कार्य, जरायु की उत्पत्ति, स्त्री के आहार का गर्भ के वर्णोत्पत्ति में प्रभाव, नेत्र की वर्णोत्पत्ति, बह्वपसता में दो जीवों का कुक्षि में आगमन, अस्थि-विरहित गर्भोत्पत्ति, गर्भस्थ शिशु के अरस्न एवं मलमूत्रादि के अत्याग का कारण।
४. गर्भिणी के स्तन-परिवर्तनों का कारण, युग्मगर्भ में गर्भिणी-चिह्न, गर्भावस्था के चतुर्थ मास में मंसस, षष्ठमास में गोक्षुरु तथा अष्टम मास में बस्ति का प्रयोग एवं गर्भज वमन।
५. गर्भस्राव एवं फाल की परिभाषा, गर्भस्राव के विभिन्न उपद्रवों की चिकित्सा, गर्भस्राव की मासानुमासिक चिकित्सा, गर्भक्षय एवं गर्भवृद्धि के लक्षण तथा कृत्रिम गर्भपात का निर्देश।
६. जाति के आधार पर विभिन्न काष्ठ से सूतिकागार का, निर्माण, प्रसव-हेतु, गर्भसङ्ग-चिकित्सा, अपरा का हाथ से निकालना एवं मूढगर्भ।
७. सूतिकाकाल, देश के आधार पर सूतिका-परिचर्या, मक्कलशूल एवं रक्तविद्रधि।
८. आर्तवक्षय, आर्तववृद्धि, नष्टार्तव तथा अष्टार्तवदोष, योन्त्या एवं स्तनविद्रधि।
९. स्तन्य का निर्माण, स्तन्य-प्रवृत्ति-हेतु, असम्यक् स्तन अधवा नाना स्तन्य एवं अपरिपुष्ट स्तनपान-जन्य दोष, स्तन-पान-वर्जित अवस्थायें, स्तन्यनाश हेतु, स्तन्यक्षय तथा वृद्धि के लक्षण एवं माला या धात्री के दुग्ध के अभाव में अन्य दुग्ध ॥

सुश्रुतसंहिता में अवर्णित परन्तु चरकसंहिता में वर्णित विषय -

- चरक संहिता में वर्णित समाज, धर्म एवं दर्शन शास्त्र से सम्बन्धित अधिकांश विषयों का सुश्रुत ने वर्णन नहीं दिया। प्रसूतिज्ञ एवं स्त्रीरोग सम्बन्धी चरक संहिता में वर्णित परन्तु सुश्रुत संहिता में अवर्णित विषय निम्न हैं:
१. विभिन्न शारीरिक या मानसिक स्थितियों में सम्भोग का परिणाम, पुत्रोद्दि यज्ञ एवं गौर वर्णादि पुत्र की प्राप्ति के लिए विशिष्ट यज्ञ।

२. गर्भ में पञ्चमहाभूतों का अवतरण क्रम, उनके स्रोत एवं निर्मित अङ्गवयव, गर्भोत्पत्ति में माता-पिता आदि के कारणत्व का विवरण, गर्भ के सत्त्वज भाव, गर्भ के सात्विक, राजसिक आदि होने का कारण, स्त्रीकादि भाव एवं युग्म-गर्भ में पुत्र या पुत्री होने का कारण ।

३. गर्भाङ्ग-विकृति में आशय, काल, आहार, विहार तथा बीज आदि के दोषों का प्रभाव एवं उपविष्टक तथा उपशुष्कादि गर्भ के विकार ।

४. गर्भिणी के मासानुमासिक लक्षण, गर्भस्थापक औषधियाँ, किंकिंस, गर्भिणी का उदवर्त, नवम मास में गर्भिणी का पथ्य तथा बस्ति, पित्त आदि परिचर्या, गर्भिणी को वमनादि देने से होने वाले उपद्रव, गर्भोदक, सूतिकागार में संग्रहणीय द्रव्य ।

५. अपरा का गर्भ के पोषण से सम्बन्ध ।

६. अचेष्ट शिशु एवं शिशु के नाभिपाक की चिकित्सा, नाभि के असम्पक्क उपकरण से उत्पन्न व्याधियाँ एवं अष्टशीतोष ।

७. असुन्दर के दोषानुसार भेद, हेतु तथा सम्प्राप्ति आदि एवं शल्य कर्म चिकित्स्य योनिशोको का चिकित्सासूत्र ।

८. बीजांशदुष्टि तथा उसमें बन्ध्या एवं वार्ता आदि की उत्पत्ति ।

महर्षि सुश्रुत सद्गुण लब्धप्रतिष्ठ शल्यवेत्ता ने अपरा के गर्भ के पोषण से सम्बन्ध, गर्भोदक तथा योनिशोको में प्रयुक्त शल्यकर्मों आदि का वर्णन क्यों नहीं दिया ? कहना कठिन है ।

अष्टाङ्गसंग्रह-

पारवर्ती लेखक वाग्भट ने अपने ग्रन्थ अष्टाङ्गसंग्रह में चरक एवं सुश्रुत दोनों ही संहिताओं में वर्णित विषयों का लगभग समावेश कर लिया है । केवल चरक संहिता में वर्णित पञ्चभूतों का अवतरण क्रम एवं उनके स्रोत, असुन्दर के भेद, अष्टक्षीर दोष तथा सुश्रुत संहिता में वर्णित युग्म गर्भ में गर्भिणी चिह्न, गर्भस्राव तथा गर्भपात की परिभाषा, दोनों संहिताओं में वर्णित गर्भ का प्रथम उत्पन्न अङ्ग आदि के ही साथ समाजशास्त्र सम्बन्धी विषय का विस्तृत विवरण नहीं दिया ।

विषय के वर्णन क्रम में अष्टसंग्रह के निम्नांकित योगदान है ।

१. रज या शोणित की बाल्यावस्था से ही उपस्थिति, रज का प्रमाण ।
२. युग्म एवं अयुग्म दिवसों में सहवास से पुत्री या पुत्र-प्राप्ति के कारण का स्पष्टीकरण ।
३. गर्भ के राजसिक तथा तामसिक भाव, देश, काल तथा अनुवृत्ति एवं शुक्र के वर्ण का गर्भ के वर्ण-निर्माण में प्रभाव, पक्षत्रय में ही सौहृद तथा रोमराजी ।
४. माता के वातलाहि दोषप्रकोपक आहारों के प्रयोग का गर्भ पर प्रभाव तथा गर्भिणी को बस्ति देने की विधि या बस्ति प्रवेशकाल में स्त्री की शारीरिक स्थिति ।
५. गर्भस्राव की अपेक्षाकृत विस्तृत चिकित्सा, उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ के वातादि दोषाधिक्य के लक्षण तथा चिकित्सा एवं वातोदर ।
६. प्रसव के लिए प्रयुक्त आस्तारण पर चर्मच्छद का प्रयोग, प्रसूता की योनिप्रेश की चिकित्सा एवं षष्ठी रात्रि का रक्षाकर्म ।
७. शिशु का उल्बक रोग, नाभिखण्डादि की चिकित्सा ।
८. स्तन्य का प्रमाण, स्तन्य अपनयन विधि एवं काल तथा विभिन्न रस या वर्ण के स्तन्यपान जन्य विकार ।
९. योनिवर्णलक्षण, योनि-नाडीवर्ण-प्रक्षालन एवं योनि-नाडीवर्ण-अप्यङ्ग यन्त्र ।

अष्टाङ्गहृदय-

अष्टाङ्गहृदय में अष्टाङ्गसंग्रह वर्णित लगभग सभी विषय का अतिरिक्त अपेक्षाकृत संक्षिप्त वर्णन है । इस पुस्तक में मूढ-गर्भ की गतिधियों का वर्णन न होकर विक्रम्य मूढगर्भ का उल्लेख है ।

सङ्कलन में प्रयुक्त अन्य सभी ग्रन्थों में उपलब्ध विषय वस्तु का पूर्ण विवरण न देकर उन उन लेखकों के विशिष्ट योगदानों का क्रमानुसार उल्लेख किया जा रहा है ।

काश्यप संहिता-

जाति के आधार पर ऋतुकाल की मर्यादा, गर्भावस्था के विभिन्न मासों में उत्पन्न व्याधियों का चिकित्सासूत्र, दोषप्राधान्य के आधार पर गर्भिणी-वमन-चिकित्सा, गर्भिणी की विभिन्न व्याधियों की विस्तृत चिकित्सा, ज्वरित गर्भिणी को प्रदत्त धूप-पानादि के परिणाम, ज्ञातहारिणी या रेवती शीर्षकान्तर्गत आर्तवव्यापद, प्राधिक गर्भस्राव, गर्भशयान्तर गर्भमृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु आदि का वर्णन, गर्भिणी, गर्भ अथवा उत्पन्न शिशु के विनाश-सूचक अरिष्ट, वरगबन्ध, रक्तजुलम का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन; आवा की प्रसव में प्रभाव, पुत्र या पुत्री के अनुसार प्रसव के समय योनिस्त्राव, प्रसवोपशान्त पुनः रजोदर्शन हेतु; पुत्र या पुत्री तथा देशादि के आधार पर सूतिका परिचर्या का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन, सूतिका-व्याधियाँ एवं उनकी अति विस्तृत चिकित्सा; ग्रहों से दूषित स्तन्य तथा धात्री की चिकित्सा का विस्तृत वर्णन एवं स्तनवज्रा/स्तनकीलक का दोष प्राधान्य के आधार पर वर्गीकरण ।

हारीत संहिता-

उपलब्ध हारीत संहिता में स्त्री की आयु का बाला, युवा आदि विभाजन, रेतस का शुक्र से पृथक् वर्णन, मूढगर्भ के वातजदि भेद, गर्भवचन की मांसानुमासिक, चिकित्सा, अपूर्ण दिवसों में प्रसव, लज्जा से भग्न-सङ्कोच तथा गर्भकोष की आपात्रता एवं मन्थर गति का मूढगर्भ के निदान एवं असाध्यता के लक्षणों में क्रमशः उल्लेख, आर्तव के अरिष्ट एवं बन्ध्या के ६ भेदों का वर्णन आदि विशिष्ट विषय मिलते हैं ।

भेल संहिता-

इस संहिता में कोई भी नवीन विषय नहीं मिलता ।

माधव निदान-

सूतिकाशोको की गणना एवं योनिचक्र का वर्णन इस ग्रन्थ के विशिष्ट योगदान हैं ।

शार्ङ्गधर संहिता-

इस ग्रन्थ में गर्भ के आठ दोषों, स्तन्य रोग के पाँच भेदों, स्त्रीदोष के तीन भेदों, सोमरोग, जरायु-रोगों के नामोल्लेख के ही साथ कुछ चिकित्सा योगों का भी वर्णन है ।

भावप्रकाश-

योनि की समीरणा आदि नाडियों, आर्तव का स्त्री शरीर की अष्टम धातु के रूप में वर्णन तथा शुक्र एवं आर्तव के कार्यों का विभाजन; योनिमृदुत्व के कारण प्रसव में क्लेश, मूढगर्भ चिकित्सका के विशिष्ट गुण; योनिसेवण, पित्तङ्ग, सोमरोग एवं मूत्राशिरास व्याधियाँ, गर्भाधाननिरोध के लिए आप्यन्तर प्रयुक्त औषधियों का वर्णन इस ग्रन्थ के योगदान हैं ।

योगरत्नाकर-

गर्भिणी की व्याधियों की अपेक्षाकृत स्पष्टर एवं विस्तृत चिकित्सा; गर्भापातक एवं स्थानिक या बाह्य प्रयुक्त गर्भाधान-निरोधक औषधियों तथा आप्यन्तर प्रयुक्त गर्भाधान-निरोधक अन्य योगों के ही साथ चिकित्सा में प्रयुक्त अन्य औषधियों तथा

रासौधियों का उल्लेख आदि विशिष्ट योगदान है।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि विषय के विकास को यद्यपि गति मन्द थी तथापि क्रमशः इसमें वृद्धि होती रही है। परवर्ती काल में यद्यपि चिकित्सा के लिए प्रयुक्त विभिन्न योगों को संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, तथापि विषय के सैद्धांतिक पक्ष में कोई विशिष्ट उन्नति या प्रगति नहीं हो सकी।

पौलनी-

संकलन में चार्क संहिता, अष्टाङ्गसंग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय के अतिरिक्त कौमारभूष के विशिष्ट आकर ग्रन्थ काश्यप-संहिता को आधार बना, वर्णित विषयों का उपयुक्त क्रमानुसार सङ्कलन कर हिन्दी अनुवाद दिया गया है। यत्र-तत्र चक्रपाणि, डलहण, इन्द्र एवं अरुणदत्त आदि टीकाकारों के विचारों को उद्धृत कर सन्दर्भों को पादटिप्पणी में दे दिया गया है। पुस्तक के अत्यधिक विस्तार एवं अधिकांशतः पुनरावृत्तिभय के कारण, माधवनिदान एवं इसकी मधुकोष व्याख्या, शार्ङ्गपर संहिता, भेल संहिता, हरित संहिता, भावप्रकाश तथा योगतत्त्वाकर में वर्णित विषय का शब्दशः अनुवाद न देकर मुख्य विषय का उल्लेख कर, इनके उद्धरणों को पादटिप्पणी में दिया गया है। एक दो स्थानों पर शार्ङ्गपर की आठमल्ल टीका तथा वङ्गसेन की भी उद्धृत किया गया है।

चिकित्सा के वर्णन में आधारभूत संहिताओं के भी विषय का अनुवाद नहीं किया गया, क्योंकि योगों में अधिकांश पुनरावृत्ति है एवं योगों तथा प्रयोग-विधि के आधार पर चिकित्सा वर्णित होने पर उसके क्रियात्मक प्रयोग में सुविधा होती है, अतः यहाँ पर सभी संहिताओं में उपलब्ध विषय का योगों या प्रयोग-विधि के आधार पर वर्णन कर, संदर्भ उस शीर्षकान्तर्गत वर्णित विषय के अन्त में पादटिप्पणी में दिए गए हैं, जिस व्याधि लक्षण की चिकित्सा आधारभूत ग्रन्थों में से केवल एक ग्रन्थ में ही वर्णित है उसमें अनुवाद परम्परा का भी निर्वाह किया गया है।

संहिताओं में वर्णित विषय का उल्लेख कर, यथास्थान विमर्श के रूप में लेखिका के स्वयं के विचार हैं, जिनमें संहिताओं में वर्णित विषय की अभिप्रेत सीमा का उल्लेखन न करते हुए, आधुनिक ग्रन्थों में उपलब्ध विषय अथवा वैज्ञानिक शक्तियों के माध्यम से विषय के स्पष्टीकरण का प्रयत्न किया गया है।

यत्र-तत्र शुद्ध पाठ लिखकर पुस्तकों के मुद्रणक्रम में समाविष्ट त्रुटियों के निराकरण का भी प्रयत्न किया गया है। पुस्तक में उल्लिखित माप एवं तौलों के आधुनिक मानक परिशिष्ट में संलग्न हैं।

आंग्ल भाषा में, संहिताओं में वर्णित विषय को पृथक् पृथक् न देकर समष्टि स्वरूप का रूपांतरण करते हुए आचार्यों के मतवैभिन्य का भी उल्लेख एवं लेखन शैली में अन्तर्द्विपरस्तर पर मान्य स्वरभेदक या ध्वनिनिर्देशक चिह्नों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दों के आंग्ल भाषा में अर्थ के लिए सर मोनियर मोनियर-विलियम एवं आर्टे के शब्दकोषों तथा आंग्ल भाषा के शब्दों की हिन्दी में लिखने पर कामिलबुल्के के शब्दकोष में लिखित उच्चारणों का आश्रय लिया गया है।

पुस्तक दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में प्रसूतितन्त्र तथा द्वितीय भाग में स्त्रीरोग से सम्बन्धित विषय का वर्णन है। द्वितीय भाग के अन्त में परिशिष्ट के अन्तर्गत चिकित्सा में प्रयुक्त वार्तव्यों, गणों या कण्ठयों में निर्दिष्ट द्रव्यों का वर्णन, औषधियों का अकारादि क्रम से व्यवस्थापन तथा उनके वैज्ञानिक नामों की उल्लेख करने का भी प्रयत्न किया गया है।

सम्पत्ति प्रस्तुत प्रथम भाग (प्रसूतितन्त्र) में सम्पूर्ण विषय को ग्यारह अध्यायों में वर्णित किया गया है चौकी नवजात-शिशु-परिचर्या, स्तनपान-निर्देश आदि की व्यवस्था बालरोग विशेषज्ञ के साथ साथ प्रसूतितन्त्र-वेत्ता को भी करनी पड़ती है अतः उन विषयों का भी यहाँ समावेश कर लिया गया है। विषय के स्पष्टीकरणार्थ यत्र-तत्र संहिताओं में वर्णित विषय-वस्तु के आधार पर निर्मित रेखाचित्रों का भी समावेश है जो लेखिका के निर्देश पर चित्रकारों ने रेखांकित किए हैं।

आधार प्रदर्शन-

उन महर्षियों एवं मनीषियों के प्रति, जिनकी रचनाओं का इस पुस्तक में प्रयोग है, कृतज्ञता की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए शब्द असमर्थ एवं लेखनी अशक्त है।

गुरुवर आचार्य प्रियव्रत शर्मा के भ्रिगुवर् वात्सल्य, रातत प्रोत्साहन, सामयिक मार्गदर्शन एवं गूढ़ विषयों के सुस्पष्ट स्पष्टीकरण का ही परिणाम है यह पुस्तक। यत्र-तत्र उल्लिखित संस्कृत पाठयोध गुरुवर का ही प्रसाद है, यदि इस पुस्तक में कुछ भी उपयोगी अंश है तो वह आपकी ही अनुकम्पा एवं निर्देशन के कारण आ सके हैं, अपने अतिव्यस्त जीवन में भी कुछ पल निकाल भूमिका लिखकर पुस्तक की उपयोगिता एवं शोभा बढ़ाई। आपके प्रति कृतज्ञता में नतमस्तक हूँ।

विभिन्न संहिताओं से विषय के सङ्कलन, उसके स्पष्टीकरण एवं टंकण आदि में समय समय पर सहयोगी डॉ० चन्दन चतुर्वेदी के द्वारा दी गई सहायता के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ।

टीकृत प्रति के संशोधन में डॉ० शृङ्गकुमारी नेगी तथा मुद्रित पुष्प के संशोधन में डॉ० रमेशदत्त शर्मा, डॉ० हरिशङ्कर तथा डॉ० अभिमन्यु कुमार ने अथक परिश्रम किया है। सम्पूर्ण शब्दानुक्रमणिका डॉ० रमेशदत्त शर्मा तथा अधिकांश शुद्धि-पत्र डॉ० अभिमन्यु कुमार की देन है। डॉ० देवेन्द्रनाथ मिश्र तथा श्रीमती सुरेशा शर्मा ने भी पूरक संशोधन में सहायता दी है। इन सभी सहयोगियों के प्रति हृदय से आभारी हूँ।

संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी का टंकण कार्य सम्पादित करने के लिए पं० देवनन्द मिश्र, श्रीरामव्यास सिंह, श्री गिरिशचन्द्र श्रीवास्तव, श्री शिवकुमार शर्मा एवं रेखाचित्र-निर्माण के लिए भाई बाबूलाल तिवारी (रत्नमन्त्र) तथा श्री जन्मक कुमार खन्ना के प्रति हार्दिक रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत ही कुशलता, शीघ्रता तथा निःस्वार्थ भाव से यथासमय कार्य पूर्ण किया।

भाई कृष्णचन्द्र चुण्णेर द्वारा प्रदत्त अष्टाङ्गसंग्रह की सूत्र से चिकित्सास्थान तक की इन्दुटीका तथा सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान की चक्रपाणि टीका पुस्तकों का उपयोग हुआ। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

पुस्तक के मुखपृष्ठ की सुसज्जित सजा के लिए श्री जनककुमार खन्ना धन्यवाद के पात्र हैं।

चौखम्बा ओरियन्टलिया परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ जिसने अनेकों बाधाओं को दूर करते हुए एक अज्ञ लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक का अतिशीघ्र प्रकाशन किया।

पूज्य पिता श्री रामशंकर तिवारी तथा अप्रजा डॉ० (श्रीमती) पुष्पावती तिवारी द्वारा प्राप्त स्नेह, वात्सल्य एवं प्रोत्साहन के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हूँ।

उन सभी महानुभावों या सहयोगियों के प्रति जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में योगदान दिया, अभारी हूँ।

अन्त में सर्वशक्तिमान के चरणकमलों में बन्दना है जीवन की त्रुटियों के लिए क्षमायाचनार्थ एवं भावी जीवन में कुछ कर सकने के आशीर्वाद।

क्षमायाचना-

भाषा एवं विषय दोनों के ज्ञानाभाव में पुस्तक-लेखन का प्रयास हास्यास्पद सा ही है, फिर भी साहस किया है पुस्तक-लेखन के दुरुह मार्ग पर प्रथम पाग रखने का, इस आशा, आकांक्षा एवं विश्वास के साथ कि विद्वद्जन अपनी रचानात्मक आलोचनाओं द्वारा भविष्य में विषय के स्पष्टीकरण में सहायता एवं प्रोत्साहन देरी पुरः कुछ कार्य कर सकने का। इस क्षेत्र की अनुभवहीनता पुस्तक के मुद्रण में आई हुई त्रुटियों एवं शैलीवैभिन्य का कारण है। यद्यपि पुस्तक के अन्त में शुद्धि-पत्र देकर त्रुटियों के निराकरण का प्रयत्न किया है फिर भी वह अपूर्ण है। इन सभी कमियों के लिए कवचद क्षमायाचना है।

दिनांक २०-२-८६

प्रेमवती तिवारी

PROLOGUE

The passage of time caused unprecedented obstacle in the progress of *āyurveda*, the oldest and most accurate science of life. The obstacle was relatively more marked in the field of *prastūtiāntṛa* and *stṛī-rogā* (obstetrics and gynecology) due to various social, ethical, moral and legal reasons.

Keen interest and inquisitiveness of the scientists world-over on the one hand and changed or advanced method of teaching of *āyurveda* on the other, has posed a big question, "Can the subject of *prastūtiāntṛa* and *stṛī-rogā* be made practically useful on the basis of material available in *āyurvedika* classics"? To answer this question, it is imperative to study the subject in its entirety with correct augmentations, explanations, redactions and understanding.

Aims—

To know the subject of *prastūtiāntṛa* and *stṛī-rogā* in *āyurveda*, study of classics as a whole is indispensable, because the subject concerned is not given at one *sthāna* or chapter, rather it is scattered in whole book, sometimes even interspersed with other subjects specially when one tries to know it, on the basis of headings given in modern obstetrics and gynecology, he/she is likely to get too much deviated from original subject, besides it is also quite time consuming task.

In every language few words are equivocal, naturally can be interpreted differently by workers, thus it is essential to know exact words used in the classics. With this idea in mind, the present book purporting to be an original work but merely a compilation is written; basic idea being the arrangement of subject from commonly read *āyurvedika* classics under the headings of today's obstetrics and gynecology, so that one is able to get systematic and comprehensive knowledge of the subject, available in *āyurveda*.

Place of prastūtiāntṛa and stṛī-rogā amongst eight branches of āyurveda—

According to presently available oldest treatise of *āyurveda* i.e. Caraka *triśūtra* or *triskandha* (three principles or three pillars) i.e. *hetu* (etiology), *liṅga* (clinical features) and *ausadha* (treatment). Though one does find names of eight branches of *āyurveda* in subsequent pages of this very book, yet, specific subjects to be incorporated in these specialities have not been spelled out. Suśruta and latter

author says that *āyurveda* descended from divine or celestial to terrene or terrestrial stage in its *aṣṭāṅga* (eight branches) shape. Suśruta has defined very vividly specific subjects of these eight branches, the clarity is again missing in Aṣṭāṅga-Saṅgraha and AṣṭāṅgaHṛdaya, which might have come up due to insistence on comprehensive or summarized description in these classics. Kāśyapa has also just enumerated eight branches, however, Hārīta has detailed the subjects of these. It appears, that during the period of Caraka a motion was set-in towards specialization, which attained maturity and stability during the period of Suśruta, thus all these eight branches had their specialists, who probably wrote their compendiums. The motion could not sustain for long, due to various social, political and economic reasons again study of *āyurveda* in its entirety started.

The subject of present book comes under '*kaumārabhṛtya*', one of the eight branches of *āyurveda*. To this particular speciality Caraka has used the term '*kaumārabhṛtyaka*', Suśruta '*kaumārabhṛtya* or *kaumāraāntṛa*', Kāśyapa '*kaumārabhṛtya*' and both Vāgbhaṭas and Hārīta '*bālācikinsā*'

As stated earlier, only Suśruta and Hārīta have detailed the subjects of these eight branches of *āyurveda*. Cakrapāṇi commenting upon the verse of Caraka-Saṁhitā says that the subject concerned with *bharaṇa* of *kuṁāra* comes under *kaumārabhṛtya*. Laxicons explain the word '*bharaṇa*' as 'procuring, carrying, bearing or act of bearing also in womb, bringing, maintaining, supporting and nourishing' etc. Accordingly the subject concerned with achievement of conception, its maintenance and delivery, then its protection, support and nourishment comes under the perview of *kaumārabhṛtya*. To know the physiopathologies of achievement of conception, the knowledge of anatomy and physiology of female reproductive system, descend of embryo as well as abnormalities of *ārtava* and *yoni*vṛṇpad (menstrual and other gynecological disorders) is essential, because in the presence of menstrual or other gynecological disorders woman may not conceive.

Suśruta says that subject related to *bharaṇa* (explained earlier) of *kuṁāra* (child), wet-nurse, disorders of milk and their treatment, diseases of the child caused by consumption of vitiated milk and affliction by *grahas* alongwith their treatment is described under *kaumārabhṛtya*. In further elaboration he writes that features of all the nine *grahas*, treatment of *skanda*, *apasmāra* (*skandāpasmāra*), *śakuntī*, *rewatī*, *pūtānā*, *andhā* (*andhapūtānā*), *muṇḍikā* (*muḥhamuṇḍikā*), *śtīpūtānā* and *naigameṣa* all *bhāgrahas*, gynecological disorders and the subject described in *śārīrasthāna* are included in *kaumārabhṛtya*. Explaining this Dāhiana says that physiology of menstruation and descend of embryo etc. described in *śārīrasthāna* also come under *kaumārabhṛtya*. Cakrapāṇi says that as antenatal management, embryology, abortions, normal labour, management of puerperium and neonate, wet-nurse, breast milk and certain diseases of children are described

in *śātrasthāna*, thus these are also included under *kaumārābhyā*. In the beginning of chapter dealing with *yoni-vyāpad* (gynecological disorders) Dhaṇḍa has mentioned that this is being written to impart knowledge of treatment for gynecological disorders responsible for failure in birth of a child. At the end of this very chapter Suśruta writes that 'now ends the *kaumārābhyā*'. Considering the explanation of word '*bharaṇa*' and above description of Suśruta alongwith its commentators, it can be said that today's obstetrics (excluding dysocias), gynecology and pediatrics come under *kaumārābhyā*. Obstructed labour was considered as a *śalya*, thus was dealt under *śalyatantra* (surgery).

Commentators Indu and Arjunadatta have limited the perview of this branch to the pediatrics, probably due to use of term '*bāla*' a 'child' by principal authors in *Aṣṭāṅga-Saṅgraha* and *AṣṭāṅgaHṛdaya* respectively. Arjunadatta has explained that due to immaturity of *deha* (body) *dhaṭu* and *bala* of the child, indistinguished state of its age or strength and influence of this specific period of life, the management adopted to treat a child, qualities of wetnurse and her milk, diseases due to vitiated milk and their treatment. Both these commentators are silent about the place or branch of *prasthāntara* and *stṛīroga* (obstetrics and gynecology).

Harīta though used the term '*bālāciktisā*', yet has included measures or process to achieve conception and its maintenance, delivery, puerperium and treatment of diseases of children under this heading. In the measures of achievement of conception, the knowledge of gynecological disorders is essential, which has already been mentioned earlier.

In olden days *āyurvedika* literature was written under monarchism, wherein birth and proper brought-up of a son (*kumāra*) as a heir was very important. Menstrual and gynecological disorders influence impregnation, non-observance of regulations prescribed or negligence during menstrual period, *ritukāla* (optimum period for fertilization) and pregnancy as well as improper management during labour can produce certain abnormalities in the child, similarly improper management of puerperal woman can influence nourishment and brought-up of the child. In other words, to get a physically and psychologically healthy and handsome son, knowledge of gynecological disorders alongwith their treatment, physio-pathology of menstrual cycle, pregnancy, labour, puerperium alongwith their management and treatment of disorders of these stages is essential. It appears that due to utmost importance of the child, it was made as pivot and entire physio-pathologies of woman revolved around it. Hypothesis becomes clearer with description of '*garbha*, *bāla* and *kumāra*' three divisions of age of a child by Kāśyapa. *Garbha* or embryo is nourished and maintained by the woman, naturally knowledge of her management becomes a part of the management of a child.

In present changed circumstances of society, due to equal importance of

woman and child, advancements in the field of medicine and specializations, the woman and child or being dealt by different specialists. Influenced by this changed attitude Gaṇanātha sen jī has accepted *prasthāntara* and *kaumārābhyā* as distinct specialties, however, he has included *stṛīroga* (gynecology) under *kaumārābhyā* (pediatrics). Till the number of branches of *āyurveda* is to be limited only to eight, this type of dichotomy is not advisable, the subject of *prasthāntara*, *stṛīroga* and *bālaroga* (obstetrics, gynecology and pediatrics) all should be accepted under *kaumārābhyā* only.

Subject of *prasthāntara* and *stṛīroga* in the books taken for collecting the matter—

From the view point of *prasthāntara* and *stṛīroga* it appears that Caraka has described bones of female pelvis; physiology of menstruation; fertilization, descend of *garbha*, *garbha* (*zygote*, embryo, fetus) including its growth, development and nourishment; *dauhṛda*, clinical features of pregnant woman; *udāvarṇa* and *kikkisā* of a pregnant woman; abortions, *upaviṣṭaka*, *upaśuśka* and *bhūtaḥṛta garbha* etc. fetal disorders and teratologic abnormalities; accouchement ward, labour, puerperium; *raktigulma*, *asṛgdara*, *yoni-vyāpad* (gynec. disorders); care of new born and diseases caused due to improper care; wetnurse and disorders of milk etc. in detail.

SuśrutaSaṁhitā is basically a compendium of surgery, naturally comparatively detailed description of anatomy of female reproductive system and obstructed labour is given, Suśruta being surgeon was conscious about medical ethics, thus has advised to take consent of guardian before dealing a case of obstructed labour. Besides above specialties Suśruta has described the entire subject given by Caraka, albeit deleting and adding a few here and there.

Subject matter given by Suśruta but not by Caraka—

1. Detailed anatomy of female reproductive system, specific components taking part in the development of different body parts.
2. *Strīśukra*, physical changes preceding menarche, formation of *ārtava* also along-with *śukra* from *rasa* in one month, formation and functions of *raja*, age of menarche and menopause, accumulation of blood within uterine vessels for whole month in menstrual cycle; effects of use of mascara etc. and coitus during menstruation, effect of seeing husband on fourth day of menstruation and *ritukāla*.
3. Functions of *mahābhūta*s in development of embryo, formation of placenta, effect of diet of mother on body-complexion of fetus, development of colour of eyes, descend of two *jīwas* in twin pregnancy, birth of boneless fetus and cause of absence of cry, micturition and defecation etc. by fetus.
4. Cause of breast changes during pregnancy, clinical features of twin pregnancy, use of meat-soup in fourth, *gokṣuru* in sixth and *basi* in eighth month of pregnancy and hyperemesisgravidam.

5. Definition of *garbhāśrāvā* and *garbhāpāta*, treatment of various complications of abortion, monthwise treatment of abortions, clinical features of *garbhavārdhi* and *garbhakṣaya*, advice for termination of pregnancy.
 6. Construction of accouchement room with different woods according to caste of the woman, causes of onset of labour, treatment of *garbhāśrāvā*, manual removal of placenta, obstructed labour.
 7. Period of puerperium, care of puerperal woman on the basis of her place of living, *makkallaśūla*, *raktavārdhi*.
 8. *Ārtavakṣaya*, *ārtavavārdhi*, *naṣṭārtava*, and eight disorders of *ārtava*, *yonyarśa* and *stanaivārdhi*.
 9. Formation of milk, cause of ejection of milk, diseases caused due to use of milk of different women or from over filled or improper breasts, unfit stages for breast feeding, causes of loss of breast-milk, clinical features during decrease or increase in quantity of breast milk, substitute milk in place of wetnurse or mother.
- Subjects not given by Suśruta but mentioned by Caraka—**
- Suśruta has not described sociological or philosophical subjects given by Caraka. Besides, following subjects have also not been given by Suśruta—
1. Effect of coitus during different physical and psychological status, *puṣṭeṣṭiyajña*, specific rituals for achievement of fair complexioned progeny.
 2. Descent of *pañcanābhūti* in embryo, sources of *pañcanābhūti* and different body parts developing from these; details of the causation of mother and father etc. all factors for conception; *sarvaja* features of fetus, cause of *sālvika*, *rājāsika* etc. features in fetus; *śrīkarabhāva* and cause of sex of children in twin pregnancy.
 3. Role of abnormalities of *āsaya*, *kāla*, *āhāra*, *vihāra* and *bija* etc. in teratologic abnormalities, *upaviṣṭaka* and *upaśuṣka* etc. fetal disorders.
 4. Clinical features of woman during different months of pregnancy, *garbhashāpaka* drugs, *kikkisa*, *udāvarta* of a pregnant woman; dietetic management, *basti* and *pieu* etc. in ninth month of pregnancy, complications of emesis etc. given to a pregnant woman, liquor amni, articles to be stored in accouchement ward.
 5. Relation of placenta with fetal nourishment.
 6. Resuscitation of asphyxiated newborn, treatment of umbilical sepsis of a new born, abnormalities due to improper cutting of umbilical cord, eight milk disorders.
 7. Classification and etiopathogenesis of *asṛgdara* and principles of surgical procedures to be used in gynecological disorders.
 8. Abnormality of *bijāṁśa* and birth of *vandhyā* and *vārā* etc. due to abnormalities of *bijāṁśa*.

Omission of reference about relation of placenta with fetal nourishment, liquor amni and even principles of surgical procedures for gynecological disorders by Suśruta, the surgeon of such a high repute, is difficult to explain.

Aṣṭāṅga Saṅgraha—

Vāgbhaṭa, the latter author, has tried to incorporate entire subject given by Caraka and Suśruta in his compendium *AṣṭāṅgaSaṅgraha*, except sociological subject, sequence and sources of *pañcanābhūti* in embryo, classification of *asṛgdara* and of descent and sources described by Caraka and clinical features of twin pregnancy, eight milk disorders described by Caraka and clinical features of twin pregnancy, definition of *garbhāśrāvā* and *garbhāpāta* described in Suśruta and part of fetal body developing first etc. given by both the authors.

Following are the contributions of *Aṣṭāṅga-Saṅgraha*—

1. Presence of *raja* or *śonita* from early childhood and amount of *raja*.
 2. Explanation of cause of birth of female or male child with the coitus done on odd or even days respectively.
 3. *Rājāsika* and *tāmasika* features of fetus; effect of place of living, season, profession and colour of *śukra* on the body complexion of progeny; presence of *dauhrda* in fortyfive days and *romarājī*.
 4. Effect on the fetus of the diet capable of vitiating *vāta* etc. *doṣas* taken by the pregnant woman and method of giving *basti* to a pregnant woman.
 5. Comparatively detailed description of abortion etc.; clinical features and treatment of *upaviṣṭaka* and *upaśuṣka* associated with vitiation of *vāta* etc. *doṣas*, and *vātodara*.
 6. Use of skin over the bed to be used during labour, bath to a puerperal woman, *yonibhrūṣa* of a puerperal woman and *rakṣākarma* on sixth night after delivery.
 7. *Ulbaka* diseases of new born and treatment of umbilical wound.
 8. Amount of breast milk, weaning and diseases due to use of milk of different tastes and colours.
 9. Description of *yonivirekṣana*, *yoniāḍhvraṇa prakṣālaṇa* and *yoniāḍhvraṇa-abhyāṅga* *yantras*.
- AṣṭāṅgaHṛdaya—**
- In *AṣṭāṅgaHṛdaya* almost entire subject given in *AṣṭāṅgaSaṅgraha* is described albeit in summarized way, however, instead of different presentations/positions of *mūḍhagarbha* only *viṣkanbha mūḍhagarbha* is mentioned.
- Instead of giving the account of whole subject, only specific contributions of other books used for collecting the subject are being given here-under—
- KāṣyapaSaṁhitā—**
- Variation in duration of *rukāla* in different castes; principles of treatment of dis-

eases afflicting the woman in different months of pregnancy, treatment of vomiting during pregnancy on the basis of predominating *doṣa*, detailed treatment of diseases of pregnant woman, effect of smoking etc. given to a febrile pregnant woman; mention of various menstrual disorders, abortions, intrauterine deaths and neonatal deaths etc. under the heading of *jātalāhīnī*; *varanabandha*; bad prognostic features of pregnant woman indicative of death of fetus, woman her self or the born child; comparatively detailed description of *raktagūṇa*; effect of *āyās* (labour pains) on progress of labour; after delivery; comparatively detailed management of puerperium on the basis of place of living and also sex of born child, puerperal disorders and their elaborate treatment; vitiation of breast milk by *grahas*; detailed description of weanurse; classification on *stanaśūnya* of *stanaśūnya* according to predominance of *doṣas*.

HārtaSaṃhitā—

Classification of epochs of woman's life in *bālā* and *mūḍhā* etc.; acceptance of *retas* as different from *śukra*; classification of *mūḍhagarbha* on the basis of *doṣas* i.e., *vāja* etc.; monthwise treatment of excessive quivering of fetus; premature labour; mention of perineal rigidity due to shyness and abnormalities/diseases of uterus alongwith slow movement under causes and bad prognostic features of *mūḍhagarbha* respectively; bad-prognostic features of *ārtava* and classification of *vandhyā* under six types.

BhelaSaṃhitā—

No specific contribution has been made.

MādhavaNidāna—

Enumeration of *sūkāroḡas* and description of *yonikanda* are its contributions.

ŚārngadharaSaṃhitā—

Enumeration of eight fetal disorders, five types of breast diseases, and three *sūkāroḡas*, *sonaroga*, *gūḍhagarbha* and *jartūyudḡa* etc. conditions and few recipes are its contributions.

Bhāwaprakāśa—

Sanīrṇā etc. *nāḍīs* of *yonī*; *ārtava* as eighth *dhātū* of female; division of functions of *śukra* and *ārtava*; delay in labour due to constitution of *yonī*; specific qualifications of woman handling obstructed labour; detailed description of *yonisamvāra*, *phirāṅga*, *sonaroga* and *mūḍhāśāra* diseases and oral contraceptives are its specific contributions.

Yogaratanākara—

Relatively detailed and clear description of treatment of diseases during pregnancy; local or external use of drugs to induce abortion or for contraceptions, additions of few more oral contraceptives, good number of recipes including *rasauśadhis* for treatment

of various conditions have been added in this book.

Preceding description clearly indicates that though the process of development was slow, yet there has been continuous progress. In latter period besides good number of recipes progress on conceptual side remained almost static.

Style—

CarakaSaṃhitā, *SuśrutaSaṃhitā*, *AṣṭāṅgaSaṅgraha* *AṣṭāṅgaHṛdaya* and specific source book of *kauṃārābhyāsa* i.e. *Kāyapa-Saṃhitā* have been taken as base books. From these books, the subject has been collected and translated in consecutive order, citing specific contributions of commentators i.e. *Cakrapāṇi* (*CarakaSaṃhitā* and *sūtrashāna* of *SuśrutaSaṃhitā*), *Dalhana* (*SuśrutaSaṃhitā*), *Indu* (*AṣṭāṅgaSaṅgraha*) and *Arunadatta* (*AṣṭāṅgaHṛdaya*), references of these commentators have been given as footnotes. Subject matter from *MādhavaNidāna* including its *Madhukosa* commentary, *ŚārngadharaSaṃhitā*, *BhelaSaṃhitā*, *HārtaSaṃhitā*, *Bhāwaprakāśa* and *Yogaratanākara* has been given in summarized way without translating in verbatim due to fear of too much repetition, however, references of all these books have also been added in footnotes. At one or two places views of *Āḍimalla* (commentator of *ŚārngadharaSaṃhitā*) and *Varṇasena* have also been cited.

While writing the treatment, path of translation has been abandoned, because of repetition of prescriptions. Moreover, description of recipes on the basis of different preparations i.e. powder, decoction etc. and/or method of use i.e. local, oral etc., gives better and practical understanding. Thus, in treatment, subject matter of all the eleven books has been given on the basis of specific preparation and/or method of use and then at the end references have been added in footnotes. However, in case, the treatment is described only in one book taken as base, the system of translation has continued.

After recapitulating textual description, own ideas are given under the heading of comments, where-in attempt has been made to give intelligible explanations on the basis of subject available in books of modern medicine or scientific logics, but without transgressing the limits of descriptions of *āyurvedika* classics.

Here and there few corrections of textual description necessitated for correct understanding of subject and probably entered during printing have been done.

In english translation, without translating the matter of each book separately, subject as a whole has been mentioned, citing the difference of opinions of authors if any. In translation internationally accepted diacritical marks have been used. While translating sanskrit words in english, Sanskrit English dictionaries of Sir Monier Monier-Williams and V. S. Apte and in writing english words in hindi, the pronunciations given in Hindi English dictionary of C. Bulcke have been followed.

In appendix, presently used weights of metric system, of those *āyurvedika* weights referred in the book, have been given.

The book is divided in two parts i.e. *Prasūtiāntra* and *Śrīroga*. At the end of second part specific ingredients of group of drugs, *ganās* or *kaṣāyās* referred in both the parts and list of drugs in alphabetical order with their botanical names have been appended.

First part i.e. *Prasūtiāntra* is divided in eleven chapters. Since knowledge of neonatal management and breastfeeding is essential even to an obstetrician, hence, the subject has been included in this book. For clarification of subject, few line-drawings made on the instructions of authoress have been added.

Acknowledgement—

To express the gratitude for those *ṛṣi's*, whose work is the basis of present book, laxicons have failed to coin befitting words, thus only mute reverence is offered.

The book is the result of paternal affection, constant encouragement, timely guidance and exact explanation of controversial subject given by my reverend teacher Prof. P. V. Sharma. Sanskrita corrections given here and there are done on his advice. If this book has any useful portion, it is due to his kind and tender guidance, but for his constant encouragements, the work would never have seen the light of the day. He has very kindly spared his valuable time for writing the introduction, which has made the book more useful. I bow before him in gratitude.

I am thankful to my colleague Dr. C. Chaturvedi for his in-valuable help rendered at every stage of this work.

In collation of typed script Dr. (Miss) S. K. Negi and in collation and correction of printed material Drs. R. D. Sharma, Harishankar and Abhinamya Kumar have done very hard work. Word index has been prepared by Dr. R. D. Sharma and major work of errata is done by Dr. Abhinamya Kumar. Dr. Devendra Nath Mishra and Mrs. Sureshta Sharma have also helped in collation and correction of printed material. I am very much thankful to these colleagues.

I shall be failing in my duty if I do not express my thanks to Pandit D.N. Mishra, Shri R. V. Singh, Shri. G. C. Srivastava and Shri S. K. Sharma for typing work and Shri B. L. Tewari (Lucknow) and Shri J. K. Khanna for making the line drawings of this book, who all have completed the work with dexterity.

My elder brother Dr. K. C. Chuneekar kindly provided me his books i.e. *Indu commentary on AṣṭāṅgaSaṅgraha (sūtra to cikitsā sthāna)* and *Cakrapāṇi commentary on sūtra-sthāna of SuśrutaSaṅhitā*. I am thankful for this help.

For decorating cover page Mr. J. K. Khanna deserves special thanks.

Chaukhanbā family deserves special gratitude, who have worked with a novice, thus inspite of facing various difficulties have published the book very efficiently and quickly.

I am extremely thankful to my father shri Rama Shankar Tewari and elder sister

Dr. (Mrs.) Pushpavati Tewari, whose affection and blessings have been a fountain source of encouragement throughout my life.

I am also thankful to all those who have helped directly or indirectly in completion of this work.

At the end I bow at the feet of almighty to forgive me for my shortcomings and bless me to do something fruitful in future.

Apology—

An attempt to write a book, inspite of ignorance about subject and language is sure to be derided, still have dared to contemplate this arduous journey by keeping first step in this direction. with the fond hope, desire and confidence that constructive criticism and suggestions of erudites will pave the way for better clarification and presentation of the subject in future and will provide me an impetus to work further. Inexperience in the field is the cause of variations and mistakes in printing. Though at the end errata is appended, however, many more mistakes must have been left. I apologise with folded hands for enumerable shortcomings of the work.

20th Feb. 1986

Premvati Tewari

अ	a
आ	ā
इ	i
ई	ī
उ	u
ऊ	ū
ऋ	rī

लृ	lr
ए	e
ऐ	ai
ओ	o
औ	au
अं (anuswāra)	in or n̄
अः (Visarga)	h

क	k	ख	ka	ग	ga	घ	gha	ङ	ṅa	च	ca	छ	cha	ज	ja	झ	jha	ञ	ña	ट	ṭa	ठ	ṭha	ड	ḍa	ढ	ḍha	ण	ṇa	त	ta	थ	tha	द	da	ध	dha	न	na	प	pa	फ	pha	ब	ba	भ	bha	म	ma
---	---	---	----	---	----	---	-----	---	----	---	----	---	-----	---	----	---	-----	---	----	---	----	---	-----	---	----	---	-----	---	----	---	----	---	-----	---	----	---	-----	---	----	---	----	---	-----	---	----	---	-----	---	----

d	ढ
dh	ध
da	ड
d	द
ttha	थ
th	त
ta	ट
na	ण
n	न
dha	घ
dh	च
da	ज
n	ञ
pa	प
ph	फ
b	ब
ba	भ
bh	भ्
bha	भा
m	म
ma	मा
y	य
ya	या

र	r
ल	ra
ल	l
व	la
व	v, w
श	va, wa
ष	ś
ष	śa
	ś
	śa

Singular
ā, ā
(Vāgbhāṣa, haridā)
ī, ī
(gāi, nādi)
u, ū etc. all others just like ā, ā

स	s
स	sa
ह	h
ह	ha
क्ष	kṣ
क्ष	kṣa
त्र	tr
त्र	tra
ज	jñ
ज	jña

Hindi	English
एक	1 (one)
दो	2 (two)
तीन	3 (three)
चार	4 (four)
पाँच	5 (five)

Hindi	English
६	6 (six)
७	7 (seven)
८	8 (eight)
९	9 (nine)

संकेत-निर्देश (Abbreviation)

(१) ग्रन्थ (Books)

अष्टाङ्गसंग्रह (Aṣṭāṅga Saṅgraha)	अ० सं०; वाग्भट (A. S.; Aṣ. Sa.; Aṣṭā. Sam; Vāgbhaṭa or Vāgbhaṭa)
अष्टाङ्गहृदय (Aṣṭāṅga Hṛdaya)	अ० ह०; वाग्भट (A. H.; Aṣ. Sa.; Aṣṭā. Sam; Vāgbhaṭa II)
काश्यप संहिता (Kāśyapa Saṁhitā)	का० सं० (Kā. KS)
चरक संहिता (Caraka Saṁhitā)	च० सं० (C. S.)
भगवत्प्रकाश (Bhāwapaśakaśa)	भा० प्र० (B. P.; Bh. P.)
भेल संहिता (Bhela Saṁhitā)	भे० सं० (Bh. S.)
माधव निदान (Mādhava Nidāna)	मा० नि० (M. N.)
योगरत्नकर (Yogaratanākara)	यो० रत्न (Y. R.)
शाङ्गधर संहिता (Śaṅgadhara Saṁhitā)	शा० सं०; (Śā. S.)
सुश्रुत संहिता (Suśruta Saṁhitā)	सु० सं०; (S. S. Su.S.)
हारीत संहिता (Hārīta Saṁhitā)	हो० सं०; (Hā. S.)

(१) ग्रन्थ

अरण्यदत्त	अरण्य०
आढमल्ल	आढ०
इन्दु	इन्दु
चक्रपाणिदत्त	चक्र० (C. P.)
डल्हण	डल्ह०
श्री विजयराक्षित श्रीकण्ठदत्त कृत मधुकोष टीका	मधु०

(३) खण्ड

पूर्व खण्ड	पू० ख०; पूर्व०
मध्य खण्ड	म० ख०; मध्य
उत्तर खण्ड	उ० ख०; उ०

(४) स्थान

सूत्रस्थान	सू०
निदानस्थान	नि०
विमानस्थान	वि०
शांतिस्थान	शा०

इन्द्रियस्थान
चिकित्सास्थान
कल्पस्थान
सिद्धिस्थान
उत्तरस्थान या उत्तरतन
खिलस्थान

(५) अन्य

(अ)
पथम स्थान
द्वितीय स्थान
तृतीय स्थान
चतुर्थ स्थान
पञ्चम स्थान
षष्ठ स्थान

(आ)
योनिरोमाधिकार
योनिव्यापच्चिकित्सा
स्त्रीरोमाचिकित्सा
क्षीरदोषचिकित्सा

इ०
चि०
क०
सि०
उ०
खि०

प्र० स्थान
द्वि० स्थान
तृ० स्थान
च० स्थान
पञ्च० स्थान
षष्ठ० स्थान

योनिरो०
योनिव्या० चि०
स्त्रीरो० चि०
क्षीरदो० चि०

चित्र-सूची (List of figures)

1 योनि के अवर्त एवं पेशियाँ (Avaratas and pests of yoni)	9
2 गर्भाशय-स्थिति (Situation of uterus)	11
3 अधोगामी धमनियाँ (Adhoga dhamanīs)	15
4/1 योनिबहिर्मुख को पेशियाँ (Pests of yonibahir mukha)	23
4/2 शुक्रार्तव प्रवेशिनी एवं गर्भाछिद्रसीञ्जित पेशियाँ (Śukrārtavapraveśini pests and pests of garbha-chidra)	24
4/3 गर्भाछिद्र संस्थित पेशियाँ (Pests of garbhachidra)	25
4/4 लक्षण एवं मुष्क के समकक्ष पेशियाँ (Pests analogous to lakṣaṇa and muska)	30
5 स्त्री-शरीर के परिप्रेक्ष्य में शुक्रार्तव (Śukra and ārtava in relation to female body)	54
6 गर्भ-पोषण (Fetal nourishment)	145
7 सूतिकागार (Sutikagāra)	148
8 स्फिगुदय को विभिन्न गतियाँ (Different presentations of sphingudaya)	149
9 पृष्ठोदय या परिच मूढगर्भ (Pṛsthodaya or parigha mūḍhagarbha)	149
10 वोजक मूढगर्भ (Bijaka mūḍhagarbha)	149
11 वोजक मूढगर्भ (Bijaka mūḍhagarbha)	149
12 प्रतिवृत्त मूढगर्भ (Pratikṛta mūḍhagarbha)	149
13 अष्टमगति या एक पाद गुदा तथा दूसरा पायु में (Eighth gati, one foot in anus other in vagina)	149
14 शिर से अवरोध (Obstruction by śira)	149
15 मुखोदय (Mukhodaya)	149
16 कुब्जहेतुदय (Presenting with kubyadeha)	150
17 मूढगर्भ-निर्हणार्थ स्त्रीस्थिति (Position of woman for delivering mūḍhagarbha)	150
18 मूढगर्भ-निर्हणार्थ उपकरण (Assets for delivering mūḍhagarbha)	151
19 उभय पादोदय में प्रसव-विधि (Method of delivery in foodings presentation)	151
20 पादोदय में प्रसव-विधि (Method of delivery in footing presentation)	152
21 स्फिगुदय में प्रसव-विधि (Method of delivery in sphingudaya)	152

गर्भस्थापक औषधियाँ (Garbhasṭhāpaka drugs or the drugs beneficial for maintenance of pregnancy)	२३८
अध्याय ६ CHAPTER 6	
गर्भिणी-व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा (Disorders During Pregnancy and their Management)	२४२
गर्भिणी की व्याधियों का सामान्य चिकित्सा सूत्र (General principles of treatment for pregnant woman)	२४२
गर्भिणी की विशिष्ट व्याधियाँ एवं चिकित्सा (Specific diseases of pregnant woman and their treatment)	२४४
गर्भावस्था के विभिन्न मासों में उत्पन्न विशिष्ट व्याधियों के चिकित्सा-सूत्र (Principles of treatment of the diseases occurring in various gestational months)	२४४
गर्भिणी को ही होने वाली व्याधियाँ (Pregnancy disorders)	२४६
गर्भज वमन (Vomiting during pregnancy)	२४६
किक्किस (Kikkisa or striae gravidarum)	२४९
अन्य व्याधियाँ (Other disorders during pregnancy)	२५४
गर्भिणी च्वर (Fever of pregnant woman)	२५४
गर्भिणी के उदावर्त की चिकित्सा (Treatment of udāvarta during pregnancy)	२६६
गर्भिणी-अतिसार (Garbhinī-atīsāra or diarrhoea during pregnancy)	२६८
गर्भिणी को स्वयं या उसके गर्भ को नष्ट करने वाले अशुभ लक्षण (Bad prognostic signs/symptoms likely to injure mother or fetus)	२८६
गर्भजन्य विषमवृत्ता (Toxaemia of pregnancy)	२९०
गर्भजन्य विषमवृत्ता में गर्भपात का निर्देश (Indication for abortion in toxæmia of pregnancy)	२९३

गर्भिणी को आक्रान्त करने वाली रैवती या जातहारिणी (Revatī or jātabhāriṇīs afflicting a pregnant woman)	२९३
जातहारिणी के द्वारा आक्रमण (नाश) योग्य स्थिति एवं काल (Appropriate condition and period for seizure by jātabhāriṇī)	२९४
जातहारिणी के भेद (Classification)	२९५
जातहारिणी-प्रवेश के सामान्य कारण (Causes of affliction by jātabhāriṇī)	२९६
दैवी आदि विशिष्ट जातहारिणी वर्णन (Description of daivī etc. specific jātabhāriṇī)	३००
जातहारिणी-लक्षण (Clinical features of jātabhāriṇīs)	३०८
जातहारिणी-आविष्ट होने पर सामान्य लक्षण (General clinical features)	३०८
साध्य जातहारिणी (Curable jātabhāriṇīs)	३०९
याय जातहारिणी (Yāpya or having tendency of relapse jātabhāriṇīs)	३१२
असाध्य जातहारिणी (Asādhya or incurable jātabhāriṇīs)	३१४
अध्याय ७ CHAPTER 7	
गर्भस्थापद् (Disorders of Fetus)	
गर्भत्वाव एवं गर्भपात (Garbhasṭvāva and garbha-pāta or abortion of first or second trimester)	३२०
गर्भत्वाव एवं पात की परिभाषा (Definition of garbha ṣṭvāva and pāta)	३२०
गर्भत्वाव या पात का निदान (Causes of abortion)	३२१
सम्प्राप्ति (Prahoguesis)	३२८
लक्षण (Clinical features)	३२९
गर्भत्वाव अथवा गर्भपात के उपद्रव (Complications of abortion)	३३१

गर्भसाव विकित्सा (Treatment of abortion)	३३४
गर्भ-चलन की चिकित्सा (Treatment of garbha calana)	३५२
गर्भपात प्रतिषेधार्थं वराणबन्ध (Varanabandha for preventing abortion)	३५५
गर्भशोष या वाताभिपन्नगर्भ (Garbhasōsa or vātibhīpanna garbha)	३५९
उपविष्टक गर्भ (Upaviṣṭaka garbha)	३६१
निदान, सम्प्राप्ति एवं सामान्य लक्षण (Etiopathogenesis and clinical features)	३६१
नागोदर या उपशुष्क गर्भ (Nāgodara or upaśuṣka garbha)	३६३
कारण, सम्प्राप्ति एवं लक्षण (Etiopathogenesis and clinical features)	३६३
उपविष्टक एवं उपशुष्क में वाताधिक्य होने पर लक्षण (Clinical features of upaviṣṭaka and upaśuṣka garbha having predominance of vāyu)	३६५
उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ में पित्त का प्रकोप होने पर लक्षण (Clinical features of upaviṣṭaka and upaśuṣka garbha dominated by pitta)	३६६
उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ में रुलेष्मा का प्रकोप होने पर लक्षण (Clinical features of upaviṣṭaka and upaśuṣka garbha dominated by śleśmā)	३६६
उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ-चिकित्सा (Treatment of upaśuṣka and upaviṣṭaka garbha)	३६७
लीन गर्भ (Līna garbha)	३७१
निदान एवं लक्षण (Etiology and clinical features)	३७१
लीनगर्भ-चिकित्सा (Treatment of līna garbha)	३७२
गर्भक्षय (Garbhakṣaya)	३७४
गर्भवृद्धि (Garbhavṛddhi)	३७५

भूतहत या नैगमेष्टत गर्भ (Bhūta or nāigameshṭha garbha)	३७६
जगत्पद दोष (Jagatyudosa)	३८७
रक्तगुल्म (Raktaguḷma)	३८७
रक्तगुल्म के चिह्नों में ही होने का कारण (Cause of its presence only in women)	३८८
निदान एवं सम्प्राप्ति (Etiopathogenesis)	३८९
पूर्वरूप (Prodromal symptoms)	३९३
लक्षण (Clinical features)	३९३
रक्तगुल्म के उपद्रव (Complications of raktaguḷma)	४०२
रक्तगुल्म की असाध्यता के लक्षण (Clinical features denoting bad prognosis)	४०२
रक्तगुल्म-विकित्सा (Treatment of raktaguḷma)	४०३
अध्याय ८	
CHAPTER 8	
प्रसवविज्ञानीय (सामान्य एवं विकृत प्रसव) (Eutocia and Dystocia or Normal and Abnormal Labour)	
सामान्य प्रसवकाल (Gestational period for normal labour)	४२४
प्रसव प्रारम्भ होने के कारण (Causes of onset of labour)	४२६
सूतिकागार (Sūkāgāra or accouchement ward)	४२७
प्रसव के समय गर्भाशयान्तर गर्भ की स्थिति (Intrauterine situation of the fetus during labour)	४३४
प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण (Clinical features of different stages of labour)	४३६
आत्मी का प्रसव में प्रभाव (Effect of āvis or accouchement force on labour)	४४१
पुरु या पुत्री के अनुसार प्रसव-पूर्व रंग (Colour of 'show' according to sex of the fetus)	४४१

प्रसव के समय परिचर्या (Management of labour)	४४२
गर्भसङ्कुच-विकित्सा या प्रसव में विलम्ब होने पर प्रयुक्त औषधियाँ (Treatment of garbha-saṅkuc or delayed labour)	४५२
अपरा पतन (Placental expulsion)	४५७
स्वाभाविक अपरा-पतन (Normal expulsion of placenta)	४५७
अपरा का पतन न होने पर उपद्रव (Complications of retention of placenta)	४५७
अपरा की पतन-विधि (Treatment of retention of placenta)	४५८
अकाल प्रसव (Akāla prasava or untimely labour)	४६५
पूर्वकालिक या अग्रजन्म शिशु का प्रसव या विप्रसव (Premature labour)	४६६
कालातीत प्रसव या अतिप्रजन्म शिशु का प्रसव (Delayed labour or post maturity)	४६८
प्रसवपूर्व रक्तसाव (Antepartum haemorrhage)	४७०
मृत एवं मूढगर्भ (Mṛtagarbha and mūḍhagarbha or intrauterine death of fetus and obstructed labour)	४७१
गर्भाशयान्तर मृतगर्भ (Intrauterine death of fetus)	४७१
निदान (Etiology)	४७१
सम्प्राप्ति (Pathogenesis)	४७४
लक्षण (Clinical features)	४७५
विकित्सा (Treatment)	४७७
मूढगर्भ (Mūḍhagarbha or obstructed labour)	४७८
परिभाषा (Definition)	४७८
मूढगर्भ-निदान (Etiology)	४८३
मूढगर्भ की सम्प्राप्ति (Samprāpti or pathogenesis of mūḍhagarbha)	४८७
मूढगर्भ के लक्षण (Clinical features of mūḍhagarbha)	४९०

असाध्य मूढगर्भ के लक्षण (Clinical features denoting incurability of mūḍhagarbha)	५०२
मूढगर्भ की विकित्सा (Treatment of mūḍhagarbha)	५०८
मूढगर्भ की चिकित्सिका/विकित्सक के गुण (The qualifications of accoucheur or accoucheuse handling mūḍhagarbha)	५०८
मूढगर्भ के सामान्य विकित्सा-सिद्धान्त (General Principles of treatment of mūḍhagarbha)	५०९
जीवित मूढगर्भ की प्रसव-विधि (औषधि एवं मन्त्र विकित्सा) (Method of delivery of alive mūḍhagarbha with medicine and mantras)	५१०
दोषिक मूढगर्भ की विकित्सा (Treatment of mūḍhagarbha due to different dosas)	५१३
मृत मूढगर्भ की विकित्सा में विलम्ब या उपेक्षा का परिणाम (Effect of negligence or delay in the treatment of dead mūḍhagarbha)	५१४
गर्भशल्योद्धारण की कठिनाइयाँ (Difficulties during extraction of garbhasālyā)	५१४
शस्त्रकर्म के पूर्व भोजन-निषेध (Contraindication of ingestion of food before surgical procedure)	५१५
गर्भ-शल्योद्धारण के पूर्व अधिपति की आज्ञा (Consent of guardian before surgical intervention)	५१६
गर्भ-शल्योद्धारण के समय स्त्री की स्थिति एवं वैद्य द्वारा हस्त-प्रवेश-विधि (The position of woman during extraction of mūḍhagarbha and method of insertion of hand by surgeon)	५१७
मूढगर्भ की हथ से आहरण करने की विधि (Procedure of manual extraction of fetus)	५१९
शस्त्रकर्मोद्धार मूढगर्भ (The mūḍhagarbha fit for instrumentation)	५२३
सचेतन गर्भ-छेदन का परिणाम (The effect of rending or decapitation and other destructive procedures of alive fetus)	५२५

मूत्रगर्भ का शस्त्रकर्म (Surgery or destructive operations for mūdhagrabha)	५२६	सूतिकाव्याधियों की सामान्य चिकित्सा (General treatment of puerperal disorders)	५६३
शल्योन्मूलन के पश्चात् चिकित्सानर्तक प्रयुक्त बलादि तैलों का वर्णन (Description of balā etc. oils used in post-operative management of mūdhagrabha)	५३४	सूतिका रोग (Sūtikā roga)	५६४
मूत्रगर्भ में उदर-विषादन (Laparotomy or cesarean section for extracting mūdhagrabha)	५३८	प्रसूता की योनिभ्रंश की चिकित्सा (Treatment of yonibhrāṇṣa i.e. uterovaginal prolapse or inversion of uterus of puerperal woman)	५७२
अध्याय ९		प्रसूता के योनिभ्रंश की चिकित्सा (Treatment of yonibhrāṇṣa or vaginal ulcer of puerperal woman)	५७३
CHAPTER 9		मक्कल शूल (Makkalla śūla or puerperal after-pains)	५७३
सूतिकाविज्ञानीय (Normal and Abnormal Puerperium)		रक्तविक्षेप (Raktavivradhi)	५७३
सूतिका की परिभाषा (Definition of sūtikā or puerperal woman)	५४३	सूतिका-ज्वर (Sūtikā-jvara or puerperal fever)	५७६
सूतिकाकाल (Sūtikākāla or duration of puerperium)	५४३	सामान्य प्रसवान्तराल (Normal duration of interpregnancy period)	५८५
प्रसवोपरांत पुनः रजोदर्शन-हेतु (The factors responsible for reappearance of menstruation after delivery)	५४५	प्रसवोपरांत योनि-गाढ़ीकरण-विधि (Medicines for constriction of vagina after delivery)	६०८
सूतिका-परिचर्या (Management of puerperal woman)	५४६	प्रसवोपरांत कुक्षि-ह्रासार्थ औषधि (Prescription for reducing the belly after delivery)	६०८
सूतिका की व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा (Diseases of puerperal woman and their management)	५५६	गर्भाधानोत्प्रेषक एवं गर्भनाश-कारक औषधियाँ या विधि (Contraceptives and abortifacients)	६०८
सूतिका की व्याधियों के कृच्छ्रसाध्य या असंध्य होने का कारण (Cause of incurability or difficult curability of puerperal disorders)	५५७	अध्याय १०	
सूतिका की व्याधियों का सामान्य चिकित्सा-सूत्र (General principles of treatment for puerperal disorders)	५५८	CHAPTER 10	
सूतिका-व्याधियों की गणना (Number of puerperal disorders)	५५९	नवजात शिशु-परिचर्या विज्ञानीय (Management of New Born Child)	
पूर्ववर्णित सूतिकाव्याधियों के सामान्य निदान (General etiology of these puerperal disorders)	५६२	नवजात शिशु की तत्काल परिचर्या (Care of new born immediately after birth)	६१४
		जन्मोत्तर अचेष्ट बालक की चिकित्सा-विधि (Resuscitation of unconscious or asphyxiated child)	६१९
		नाभि-उपकल्पन-विधि (Method of cutting of umbilical cord)	६२१
		नवजात शिशु के सद्यः स्नान के लिए प्रयुक्त विशिष्ट जल एवं स्नान-विधि (Procedure of bath of neonate and water to be used for bathing)	६२२

- परिध मूढ गर्भ को प्रसव-विधि (Method of delivery of parigha mūdhagrabha)
- बीजक मूढ गर्भ को प्रसव-विधि (Method of delivery of bijaka mūdhagrabha)
- मुखोदय की प्रसव-विधि (Method of delivery in mukhodaya)
- शीर्षोदय में शिरोविदारण एवं निर्हरण-विधि (Craniotomy in obstruction due to śira)
- मुखोदय में शिरोविदारण (Craniotomy in mukhodaya)
- तिर्यगागत में अङ्गुष्ठेदन (Destructive operation in tiryagūḍhaya)
- जठरोदय में उदरविदारण (Evisceration in jātharodaya)
- स्फिगुदय में अङ्गुष्ठेदन (Destructive operation in sphigūdaya)
- उदरविषादन (Laparotomy)
- कुमारगार (Kumārāgāra)

521
522
522
527
528
528
529
530
539
631

विषयावलि (CONTENTS)

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
द्वितीय संस्करण के लिए दो शब्द	७	स्त्री-शरीर की विशिष्ट अवस्थाएँ (Specific epochs of woman's life)	३६	मैथुन के लिए अयोग्य स्त्री की अन्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएँ एवं संयोग का परिणाम (Contraindicated conditions of woman for coitus and their effects)	८२
Two words about second edition	८	स्त्री की आयु की विभिन्न अवस्थाओं में दोषों की स्थिति (Status of doshas in these epochs of woman's life)	३८	सामान्य मैथुन की स्थिति एवं विभिन्न स्थितियों में मैथुन विशेष तथा उनके परिणाम (Normal and abnormal postures for coitus and their effect)	८५
भूमिका	९	ऋतुसावादि के द्योतक विभिन्न शब्द (Different words used to denote menstrual blood and ovum etc.)	३८	गर्भोत्पत्ति के लिए आवश्यक घटक (Factors essential for conception)	८६
आमुख	१५	आर्तव, रज या रक्त शब्दों का कुछ अन्य अर्थों में प्रयोग (Other substances for which also these words are used)	४०	पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति के लिए संयोगादिस (The days of coition for having a male or female child)	८८
Prologue	१५	स्त्रीशुक्र (Female Sūkṛa)	४५	सुगमयुग दिवसों में संयोग से पुत्र या पुत्री के जन्म का कारण (The cause of birth of male or female on even or odd days respectively)	८९
Key to transliteration	१४	शुक्रधातु (स्त्री-शरीर के परितेक्ष्य में) (Sūkṛadhātu in relation to female body)	४९	ऋतुकाल की उत्तरोत्तर रात्रियों में गर्भाधान का परिणाम (Effect of impregnation on different days of ratrikāla)	९०
संकेत-निर्देश (Abbreviations)	३४	रज, शोणित, आर्तव का वर्णन (Description of rāja, śonita or ārtava)	५०	गर्भाग्रासि के लिए कर्तव्य (Specific acts for achieving conception)	९१
चित्र-सूची (List of figures)	३६	रजोदर्शन के पूर्व बाला के शारीरिक परिवर्तन (Changes before menarche)	६०	अध्याय ४	
अध्याय १		ऋतुचक्र (Menstrual cycle)	६१	गर्भ-विज्ञानीय अध्याय (Embryology)	
CHAPTER 1		अध्याय ३	६२	CHAPTER 4	
स्त्री-शरीर-रचना (Anatomy of female Reproductive System)		CHAPTER 3		गर्भ-विज्ञानीय अध्याय (Embryology)	
श्रोणि (Waist or pelvis)	३	गर्भाधान-विधि (Method of Impregnation)		गर्भ की परिभाषा (Definition of garbha or embryo)	१०५
भग (Vulva)	५	विवाह एवं गर्भधारण के योग्य आयु (Proper age for marriage and first conception)	७९	गर्भकक्रान्ति (Process of descent of various components in embryo)	१०६
योनि (Vagina)	६	अतिबाला या अतिवृद्धा में गर्भधारण-निषेध एवं परिणाम (The result of impregnation in very young or old woman)	८१	गर्भ के मुख्य षड्घटक या षड्धातु (Six major components or śaḍdhātu of fetus)	१०९
गर्भाशय (Uterus)	१०			मन, आत्मा एवं पञ्चमहाभूतों का गर्भ में अवतरण क्रम (The sequence of descent of mana, ātma and pañcamahābhūtas in embryo)	१११
आश्व्यन्तर द्योतस् या आर्तववह स्रोतस् (Ārtavaavahā srotas)	१३				
धमनी (Arteries or channels)	१४				
शिराएँ (Veins)	१६				
मर्म (Vital parts)	१६				
पेशी (Peshi or muscles)	२०				
अध्याय २					
CHAPTER 2					
ऋतुचक्र एवं उसका शारीर-क्रिया विवेचन (Physiology of Menstrual Cycle)					
शारीरिक वृद्धि की अवस्थाएँ (Stages of life according to development)	३२				

बालक की सामान्य परिचर्या (General nursing care of child)	६२३	स्तन्यसम्पत् या शुद्ध स्तन्य के लक्षण (Stanyasah-nipat or characteristics of normal breast milk)	६५१
रक्षाकर्म (Rakshakarma or measures adopted to protect the child against diseases)	६२३	तैलवर्णीदि स्तन्य-पान का प्रभाव (Effect on the child of the milk having different colours)	६५२
शिशु की जन्म से लेकर चतुर्थ दिवस तक की आहार व्यवस्था (Feeding schedule of neo-nale from first to fourth day after birth)	६२७	स्तन्यनाश एवं स्तन्यक्षय (Stanyanāśa and stanya-kṣaya)	६५३
शिशु का नामकरण संस्कार (Nāmaning ceremony of the child)	६२८	स्तन्यवृद्धि (Stanyavṛddhi or increase in amount of milk)	६५८
नवजात-शिशु की असम्यक् परिचर्या-जन्य व्याधियाँ (Diseases afflicting the child due to improper care immediately after birth)	६३२	धानो या माता के स्तन्य के अभाव में अन्य उपयोगी दूध (Substitute milk in case of non availability of milk of mother or wet nurse)	६५१
नाशिमल व्याधियाँ (Diseases of umbilicus)	६३३	स्तन्य अपनयन का काल (Stanya apānayaṇa-kāla or weaning period)	६६०
उल्बक (Ulbaka)	६३६	स्तन्य अपनयन-विधि (Stanya apānayaṇa-vidhi or method of weaning)	६६१
अध्याय ११ CHAPTER II		धानो-चिकित्सा (Dhātā-cikitsā or treatment of wet-nurse)	६६१
स्तन्य एवं धानो-प्रकरण (Stanya or Breast Milk and Dhātā or Wet Nurse)		धानो के मिथ्याहार जन्य षष्ठी रोग (Ṣaṣṭhi disease caused by abnormal dietetics of wet nurse)	६७०
स्तन्य-निर्माण (Formation of stanya or breast milk)	६३८	धानो की प्रकृति, प्रजा या स्तन्य की मात्रा का शिशु पर प्रभाव (Effect of prakṛti, parity of wet nurse or amount of milk on the child)	६७१
स्तन्य-प्रवृत्ति-हेतु (Cause of stanya pravṛtti or milk ejection)	६४०	शिशु के व्याधि-युक्त होने पर धानो की शोधन-चिकित्सा (Purifying measures for wet-nurse in the diseases of breast-fed infant)	६७१
स्तन्य का प्रमाण (Amount of stanya)	६४२	स्तन्यदुग्धि (Abnormalities of breast-milk)	६७२
धानो (Dhātā or wet-nurse)	६४२	सन्दर्भ ग्रन्थ (Bibliography)	७१४
स्तन-सम्पत् (Stanasampat or merits of breasts)	६४६	परिशिष्ट १ - मान (Appendix I - Measures)	७११
असम्पत् स्तनजन्य दोष (Abnormalities due to feeding with imperfect breasts)	६४६	परिशिष्ट २ - औषधि-योग सूची (Appendix II - List of Recipes)	७२१
स्तनपान-विधि (Method of breast feeding)	६४७	अनुक्रमणिका	७३१
नाना स्तन्यपान-परिणाम (Effect of lactation by different women)	६४८	Index	७३३
अपरिचित स्तन्यपान जन्य विकार (Diseases due to feeding with unexpressed breasts)	६४९		
स्तन्यपान वर्जित अवस्थाएँ (The woman unfit for lactation)	६५०		

आयुर्वेदीय प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग

(ĀYURVEDĪYA PRASŪTĪTANTRA EVAM STRĪROGA)

प्रथम खण्ड

प्रसूतितन्त्र

Part I

(PRASŪTĪTANTRA)

अध्याय १

CHAPTER I

स्त्री-शरीर-रचना

(ANATOMY OF FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के समकक्ष आधुनिक संहिताओं में शरीर-रचना का उतना विस्तृत एवं सुस्पष्ट वर्णन दृष्टिगोचर नहीं होता, फिर भी यत्र-तत्र वर्णित विभिन्न संदर्भों को एक स्थान पर संग्रह करने से अंगों का एक सामान्य स्वरूप सामने आ जाता है।

The descriptive anatomy of female reproductive system is not so intelligible and clear in Ayurvedika texts as in allopathic books of anatomy, however, on collecting scattered references available here and there, a gross picture emerges out.

श्रोणि (Waist or pelvis)

(अ) सामान्य माप (Normal measurements)

पुरुषोः प्रमाणविस्तीर्णं स्त्रीश्रोणिः; अष्टादशाङ्गुलविस्तारयुः। तत्प्रमाणं पुरुषस्य कटी।

(सु० सं० सू० ३५/१२)

पूर्वभागो गुरुः पुंसामधोभागस्तु योषिताम्। (सु० सं० सू० ४६/१३२)
कुमाराणामुत्सु विशालतरं जघनं तु कुमारिणाम्। (का० सं० सू० २८/६)

पुरुषों के उरस् के प्रमाण की स्त्री की श्रोणि होती है। स्त्री के उरस् का विस्तार १८ अंगुल का होता है। पुरुष की कटि का भी यही अर्थात् १८ अंगुल प्रमाण होता है। पुरुषों का पूर्वभाग (वक्ष) एवं स्त्रियों का अधोभाग अर्थात् कटि अधिक विस्तृत होती है। टीकाकार चक्रपाणि ने २४ अंगुल का पुरुष का उर एवं उसी प्रमाण की स्त्री की श्रोणि का वर्णन किया है, टीकाकार डल्हन ने १२ एवं २४ अंगुल का पुरुष का उर, इस प्रकार दो मतों का प्रतिपादन किया है। टीकाकारों के मत से यह प्रमाण स्त्री या पुरुष के यौवन प्राप्त होने के बाद होते हैं। टीकाकार डल्हन ने उरसन्धि के नीचे एवं सरसन्दिर के ऊपर के भाग को श्रोणि माना है।

महर्षि काश्यप ने भी कुमारों के उरस् एवं कुमारियों के जघन के विशालतर होने का वर्णन दिया है।

१. (अ) चतुर्विंशत्यङ्गुलमुतोविस्तारयुः, तत्प्रमाणं स्त्रीश्रोणिर्नैवा, अष्टादशाङ्गुलविस्तारयुः स्त्रिया एव। अत्र स्त्रीश्रोणिपुरुषोऽप्रभूतनामङ्गानां केषादिबोधन एव सम्पूर्णमानता भवति। (सु.सं.सू. ३५/१२ की चक्रपाणि टीका)
- (ब) श्रोणित्रोसन्धेरधस्तात् सरसन्दिरौपरित्तन विभागः। पुरुषोरो द्वादशाङ्गुलं, तत्प्रमाणं स्त्रीश्रोणिरित्यर्थः। अन्येषां मते चतुर्विंशत्यङ्गुलविस्तारयुः इतिः तन्मते स्त्रीश्रोणिरपि तत्प्रमाणैवेति। अष्टादशाङ्गुलविस्तीर्णमुः स्त्रिया इत्यर्थः। (सु० सं० सू० ३५/१२ की डल्हन टीका)
- (स) तत्र स्त्रीश्रोणिपुरुषोऽप्रभूतानां यौवन एव यथोक्तप्रमाणता भवति न त्वत्येवमसि। (सु.सं.सू. ३५/१३ की डल्हन टीका)

The measurement of chest of male and waist of female is identical. The chest of female is 18 *angulas* so is the waist of male. The chest of male is said to be 12 and 24 *angulas* by Dalhana and 24 *angulas* by Cakrapāṇi. The chest of male and waist of female is relatively broader. Dalhana opines that these measurements are attained after maturity; and *śroni* is below *uravandhi* and above *smaramandira*.

विमर्श (Comments)

टीकाकार इच्छण ने उरु-सन्धि के नीचे एवं स्मरमन्दिर से ऊपर के भाग को श्रोणि माना है। उरु-सन्धि, उरु अस्थि-शिर के श्रोणिफलक से सन्धि स्थान का द्योतक माना जा सकता है। यदि दोनों ओर की इन सन्धियों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाय तो यह स्मरमन्दिर (पराशरिणिका) के किञ्चित् ऊपर से जाएगी। पित्र्यों में श्रोणिफलक से उरु-अस्थि के संयोग-स्थान के ऊपर त्वचान्तरात् वसा का अधिक्य होने से यह स्थान सर्वाधिक विस्तृत दिखाई देता है। आधुनिक विज्ञान में कतिपय दशकों पूर्व गर्भिणी-परीक्षण करते समय उरु अस्थि के वृहत् कण्टकों के बीच की दूरी का माप स्त्री-श्रोणि की प्रासंगिक स्थिति-निर्धारण के लिए किया जाता था, यह माप श्रोणि के बहिर्माण से प्राप्त व्यक्तियों में अपेक्षाकृत बड़ा होता है, सम्भवतः इसी दृष्टिकोण से स्त्री को श्रोणि को अधिक विस्तृत लिखा गया हो।

Śroni is said to be the area below *uravandhi* and above *smaramandira*. *Uravandhi* refers to union of femur head with pelvic bones. If a straight line is drawn between both these joints, it will pass slightly above the clitoris. In women, good quantity of subcutaneous fat is deposited above these joints, making this area quite broad. Few decades back during external pelvimetry intra-trochanteric diameter was measured to assess the female pelvis. This diameter is relatively bigger in comparison to other diameters obtained by external pelvimetry. Probably, this could be the reason for description of wide female's waist.

(आ) श्रोणि की अस्थियाँ एवं उनका आकार (Number and type of bones in pelvic cavity)

द्वे श्रोणिफलके, एक भगारिश्च । (च० सं० शा० ७/६)
श्रोण्यां पञ्च, तेषां गुदभगानितम्बेषु चत्वारि, त्रिकसंश्रितमेकम् । (सु० सं० शा० ५/१९)
एकैकं भगो त्रिके । नितम्बयोश्च द्वे । (अ० सं० शा० ५/७०)
तेषां—नितम्ब—शिरःसु कपालानि । (सु० सं० शा० ५/२०)
तानि जानुनितम्ब—कपालसंज्ञानि । (अ० सं० शा० ५/७२)

महर्षि चरक के मतानुसार श्रोणिगुहा के निर्माण में दो श्रोणिफलक एवं एक भगारिश्च इस प्रकार तीन अस्थियाँ भाग लेती हैं। महर्षि सुश्रुत ने गुदास्थि एवं भगारिश्च एक-एक, नितम्ब्यास्थियाँ दो एवं त्रिकारिश्च एक, इस प्रकार पाँच अस्थियाँ गिनाई हैं। वाग्भट में भग एवं त्रिक में एक-एक तथा नितम्ब में दो, इस प्रकार चार अस्थियों का उल्लेख है। नितम्ब में कपालारिश्चयौ होती हैं।

Caraka has enumerated three bones i.e. two *śroniphallaka* and one *bhagāśchi*; Suśruta mentioned five - one *gudāśchi*, one *bhagāśchi*, two *niṭambāśchis* and one *trikāśchi*. Vāgbhaṭa wrote four i.e. one each in *bhaga* and *trika* and two *niṭambāśchis*. The bones of *niṭamba* are of *kapaḍā* (flat) type.

विमर्श (Comments)

आचार्यों के मत-वैभिन्य का कारण सम्भवतः अनुक्रियास्थि का सुश्रुत संहिता में गुदास्थि नाम से स्वतन्त्र वर्णन एवं

चक्र संहिता में त्रिकारिश्च को भी श्रोणिफलक का ही एक अंग माना जाना है।

Suśruta has enumerated *gudāśchi* or coccyx as a separate bone and Caraka has included even *trikāśchi* or sacrum in hip bones, that is why the difference in number is seen.

(इ) श्रोणि की संधियाँ (Joints of pelvis)

त्रयः कटीकपालेषु । (सु० सं० शा० ५/२६)
गुदभगानितम्बेषु सामुद्र्याः, कटीकपालेषु तुत्रसेवन्वयः । (सु० सं० शा० ५/२७)
त्रयः कटीकपालेषु । (अ० सं० शा० ५/७५)
गुदभगानितम्बेषु सामुद्र्याः कटीकपालेषु तुत्रसेवनीसंज्ञाः । (अ० सं० शा० ५/७७)

कटीकपालों में तीन संधियाँ होती हैं। गुद, भग एवं नितम्ब में सामुद्र्या तथा कटीकपालों में तुत्रसेवनी संज्ञक संधियाँ होती हैं। महर्षि वाग्भट ने उपर्युक्त वर्णन सदृश ही लिखते हुए 'तुत्रसेवनी' के स्थान में तुत्रसेवनी शब्द दिया है।

Flat bones of pelvis have three joints which are *lunna sevani* (suture) type. In *gudā*, *bhaga* and *niṭamba* the bones have *sāmudrā* type of joints.

भग (Vulva)

द्वदशाङ्गुलानि भगविस्तारः । (सु० सं० सू० ३५/१२)

भग का विस्तार १२ अंगुल का होता है। आचार्य इच्छण ने भग से योनि एवं विस्तार से रंध का अर्थ मानकर इस द्वदशाङ्गुल परिणह को कामसूत्र वर्णित हस्तिनी जाति की स्त्रियों का भग-प्रमाण बताया है। अन्यत्र टीकाकार इच्छण ने इसका आकार पिप्पल-पत्र सदृश लिखा है।

Vulva is of twelve *angulas*. According to commentator Dalhana, this is the measurement of vaginal introitus of the women called *hastini* in the books of sexology, at other place it is said to resemble leaf of *pippala*.

विमर्श (Comments)

इच्छण लिखित परिणह से परिधि का अर्थ ले, वाग बृहत् भगोष्ठ-भगयोदिका-दक्षिण बृहत् भगोष्ठ-मूलाधार इस प्रकार परिधि बनाएँ तो सामान्य स्त्री का भग-प्रमाण द्वदशाङ्गुल प्रमाणित हो जाता है। पिप्पलपत्र सदृश वर्णन आकृति-साम्य के कारण किया गया होगा क्योंकि पिप्पल-पत्र आकृति में त्रिकोणाकार सा होता है जिस त्रिकोण की पार्श्व रेखाएँ गोलाभ होती हैं। भग भी कुछ त्रिकोणाकार सा ही होता है जिस त्रिकोण का आधार जवनशैल तथा शिखर योनिबहिर्मुख एवं गुदद्वार के बीच होता है।

The twelve *angulas* measurement seems to be description of circumference of entire vulva instead of introitus of vagina. Its simile with leaf of *pippala* might have been given due to resemblance in shape. The leaf is triangular, having slight convexity of lateral

१. भगो योनिः, तस्य विस्तारो रन्ध्रः, तस्य परिणहो द्वदशाङ्गुलः, इदं तु भगप्रमाणं हस्तिनीजातिस्त्रिया ज्ञेयम्, कामशास्त्रोक्तत्वात् । (सु० सं० सू० ३५/१२ इच्छण टीका)

२. अथस्ताद् रत्नबर्हं स्मरतपस्याधः अर्तवहम् । स्मरतपत्रं भाग्योपरितने भगो । उक्तं च— विगुलिपितपत्रसमाकृतेवयवस्य शिरस्तलमाश्रितम् । सकलकामशिरममुचुचिर्वातं निगदितं मदनतपववारम् ॥ (सु० सं० शा० ५/१० इच्छण टीका)

borders, vulva is also some-what triangular having its base at mons pubis and apex mid way between vaginal introitus and anal orifice, with slight convexity of its lateral walls.

स्मरातपत्र या भगशिश्निका (Clitoris)

इसका वर्णन टीकाकार डल्लण ने किया है। यह, बड़े पिप्पल-पत्र सदृश आकृति के अङ्ग भाग के ऊपर के भाग में स्थित होता है, इसके नीचे आर्तव-वहन का स्थान या योनि-बहिर्मुख होता है। कामकला के समय यह अङ्ग अत्यन्त हृषण युक्त होता है।^१ अन्वय इसके लिए स्मरमन्दिर शब्द भी आया है।^२ आचार्य भगमिश्र ने इसके लिए मदनातपत्र शब्द का प्रयोग किया है।^३

Smaraṭapatra is situated in upper portion of the organ resembling leaf of *pippala* i.e. vulva, below to this is the orifice for discharge of menstrual blood. During sexual act it is highly stimulated/erectile structure. Words *smaramandira* and *madanaṭapatra* are also used for this.

योनि (Vagina)

(अ) बहिर्मुख (External orifice)

श्रवणचन्द्रन.....। नव स्रोतसि नराणां बहिर्मुखाणि। एतान्येव स्त्रीणामपराणि च त्रीणि-द्वे स्तनयोश्चलाद्रक्तवर्हं च। (सु० सं० शा० ५/१०)

.....अन्यानि च त्रीणि स्त्रीणां स्तनौ रक्तपथश्च। (अ० सं० शा० ६/३४)

श्रवण नयनादि बहिर्मुख नौ स्रोतस् पुरुषों में होते हैं, स्त्रियों में दो स्तन में एवं एक रक्त को नीचे की ओर वहन करने के लिए तीन अधिक होते हैं।

आचार्य डल्लण ने इस अंग की व्याख्या करते हुए लिखा है कि भाग के ऊपर के भाग में स्थित स्मरातपत्र (कामेच्छा में अत्यधिक उत्तेजित होने वाले अंग) के नीचे यह आर्तववह स्रोतस् स्थित है। इस अंग की व्याख्या के लिए साहित्यिक उद्धरण भी दिया है (सन्दर्भ १)।

अष्टाङ्गसंहकार ने भी दो स्तन एवं एक रक्तपथ इस प्रकार तीन स्रोतस् स्त्रियों में अधिक माने हैं। टीकाकार इन्दु ने इन्हें स्पष्टतया बहिर्मुख स्रोतस् माना है।^४

आचार्य भगमिश्र ने दो स्तन एवं एक गर्भ-वर्तन इस प्रकार तीन रज्ज्व स्त्रियों में अधिक माने हैं।^५

Females have three extra external orifices, two in breasts (one in each breast) and one downwards to excrete *ārtava*, which is situated below the *smaraṭapatra* (clitoris).

१. सु० सं० शा० ५/१० डल्लण टीका (पृष्ठ ५)।
२. सु० सं० सु० ३५/१२ डल्लण टीका (पृष्ठ ३)।
३. भा० प्र० पूर्व० ३/१८ (पृष्ठ ७)
४. स्त्रीणां तु त्रीण्यधिकानि.....इति बाह्यानि स्रोतसि॥ (अ० सं० शा० ६/३४, इन्दु टीका)
५. स्त्रीणामपराणि च त्रीणि स्तनयोर्भक्तमसि॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/१६९)

विमर्श (Comments)

कतिपय आधुनिक विद्वान् गर्भाशय-मुख या गर्भाशय, योनि एवं इनकी रक्तवाहिनियाँ आदि रक्तवह स्रोतस् से मानते हैं। रजोवह स्रोतस् का वर्णन सभी बहिर्मुख स्रोतसों के साथ होना एवं आचार्य डल्लण के मतानुसार भगशिश्निका के नीचे इसकी स्थिति इस अंग के योनिद्वार होने के प्रमाण स्वरूप दिये जा सकते हैं।

Some recent workers interpret *ratnavaha strotas* as uterus, cervix, vagina and its vasculature; however, due to its enumeration amongst external orifices and situation below clitoris, it appears to be description of vaginal orifice or introitus.

(आ) योनि की आकृति (Shape of yoni)

शङ्खनाभ्याकृतिर्घोसिस्थ्यावर्ता सा प्रकीर्तिता। (सा च कीर्तिता-भा० प्र०)
तस्यास्तीत्ये त्वावर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। (सु० सं० शा० ५/४३ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/३९ तथा ८६ व ८७)

योनिस्तु शङ्खनाभ्याकृतिस्थ्यावर्ता तस्यास्तीत्ये आवर्ते.....गर्भशय्या। (अ० सं० शा० ५/४९)

योनि की आकृति शंखनाभि सदृश होती है। इसमें तीन आवर्त होते हैं। तीसरे आवर्त में गर्भशय्या स्थित होती है। अष्टाङ्गसंहकार ने भी लिखा है कि योनि शंखनाभि के आकार की होती है, उसके तीसरे आवर्त में गर्भशय्या रहती है। टीकाकार इन्दु ने स्पष्टीकरण दिया है कि गर्भशय्या योनि के तीसरे आवर्त में प्रतिबद्ध रहती है।^१

Yoni resembles *śankhanābhi* (bollow portion of conch shell) in shape and has three *āvartas* (envelops or circles). *Garbhaśayya* is attached in third *āvarta*.

(इ) योनि की नाड़ियाँ एवं उनकी विशेषता (Nāḍīs of yoni and their specifications)

मनोभवागामुखेऽवलानां तिस्तो भवन्ति प्रमदजानानाम्। समीरणा चन्द्रमुखी च गौरी विशेषमसामुपवर्णयामि॥ प्रधानभूता मदनातपत्रे समीरणा नाम विशेषेनाडी। तस्या मुखे यत् परितं तु वीर्यं तन्निष्कलं स्यादिति चन्द्रमौलिः॥ या चापरा चान्द्रमसी च नाडी कन्दपीहे भवति प्रधाना। सा सुन्दरी योषितमेव सृते साध्या भवेत्स्वरतोत्सवेषु॥ गौरीति नाडी यदुपस्थगर्भे प्रधानभूता भवति स्वभावात्। पुत्रं प्रसृते बहुधाऽङ्गना सा कष्टोपभोग्या सुतोषविष्टा॥

(भा० प्र० पूर्व० ३/१७ से २०)

स्त्रियों के मनोभवागामुख (स्त्रीजननाङ्ग या योनि) में समीरणा, चन्द्रमुखी एवं गौरी नामक तीन नाड़ियाँ होती हैं जिनकी विशेषता का वर्णन इस प्रकार है-

मदनातपत्र (भगशिश्निका) में प्रणारूप से समीरणा नाम की नाड़ी रहती है जिसके मुख में यदि शुक्र गिरता है तो वह निष्कल होता है।

जिस स्त्री के कन्दपीहे (योनिनालिका-मध्य) में प्रधानरूप से चान्द्रमसी नामक नाड़ी होती है वह स्त्री रति में सुख-साध्य एवं कन्या-प्रसविनी होती है।

स्वभाव से ही जिस स्त्री के उपस्थगर्भ (योनिनालिका की अत्यधिक गहराई) में गौरी नामक नाड़ी होती है वह कष्टोपभोग्या या अधिक रति से संतुष्ट होने वाली एवं अधिकोशतः पुत्र-प्रसविनी होती है।

१. सा (गर्भशय्या) च योनौ शंखनाभ्याकृत्या तृतीय आवर्ते निबद्धा। (अ० सं० शा० ५/४९ इन्दु टीका)

In *manobhavadgāra-mukha* (vaginal canal) of females there are three *nāḍīs*: *saṁvāraṇā*, *candamukhī* and *gaurī*.

At *madanālapāra* (clitoris) is mainly *saṁvāraṇā*, *śukra* (semen) falling over it becomes futile.

The woman having mainly *candamasi* in *kandarpagheha* (mid vaginal canal) is easily satisfied with coitus and delivers female children.

Sexual satisfaction to the woman possessing *gaurī nāḍī* in *upasthagarbha* (depth of vaginal canal) is attained with difficulty and she delivers usually male children.

विमर्श (Comments)

साहित्य में योनि शब्द प्राणिमों के जाति-वैभिन्न्य का द्योतक है, पर आयुर्वेदिक संहिताओं में यह स्त्री-जननांग के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द योनिनलिका का ही द्योतक न होकर अधिकांशतः स्त्री-जननांगों के समष्टि स्वरूप के लिए एवं कहीं-कहीं पृथक्-पृथक् अंगों के वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणार्थ योनि-स्थित विशिष्ट पेशी-वर्णन, योनि-व्यापद् एवं काश्यप वर्णित बाला की हीन योनि आदि समस्त स्त्री-जननांगों के द्योतक हैं। योनि की नाड़ियाँ, योनि-कण्डु, योनि-अतिवैच्छल्यादि वर्णन योनिनलिका एवं भाग को इंगित करते हैं। अष्टाङ्गहृदय आदि में वर्णित ऋतु के अन्त में योनि के द्वारा शुक्र का धारण न करना वर्णन में योनि शब्द गर्भाशय एवं गर्भाशय-ग्रीवा का द्योतक है।

योनि की आकृति शंखनाभ-सदृश मुख में संकुचित एवं मध्य में विस्तृत होती है। शरीर-रचना की पुस्तकों में योनिनलिका का भी लगभग ऐसा ही वर्णन मिलता है यथा अविवर्हित स्त्री में अधोभाग की परिधि लगभग ४-५ से. मी. एवं ऊर्ध्वभाग की परिधि इससे दुगुनी होती है।

योनि-स्थित आवर्तों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। डॉ. जोशी ने प्रथम आवर्त से योनिनलिका एवं पार्श्व-स्थित रचनाएँ, द्वितीय आवर्त से गर्भाशय-ग्रीवा एवं पार्श्व-स्थित रचनाएँ एवं तृतीय आवर्त से गर्भाशय एवं पार्श्व-स्थित रचनाओं को ग्रहण किया है। आचार्य घाणेकर ने योनिनलिका-स्थित श्लेष्मल कला के उभारों का वर्णन किया है। इन आवर्तों की अन्य भी व्याख्या दी जा सकती है।

(१) आवर्त का शाब्दिक अर्थ घुमाव या मोड़ या चक्कर आदि होता है। योनिनलिका स्त्री-श्रोणि के लगभग समानान्तर स्थित होती है। यह भाग से प्रारम्भ हो १/३ भाग तक सीधी जा फिर थोड़ा सा पश्चिम भाग की ओर झुककर पीछे गर्भाशय की ओर जाती है। अतः प्रथम आवर्त से योनि का बहिर्मुख, द्वितीय आवर्त से पश्चिम की ओर झुकने वाला स्थान या सम्पूर्ण योनिनलिका एवं तृतीय आवर्त से गर्भाशय-ग्रीवा के पार्श्व का योनि भाग (तोरीणिका) लिया जा सकता है।

(२) यदि आवर्त से योनि के चारों ओर की रचना ग्रहण की जाय, तो प्रथम आवर्त मूत्रनलिका एवं मलाशय या मलद्वार से पृथक् करने वाला नाड़ियों एवं रक्तवाहिनियों से युक्त सौत्रिक एवं संयोजक-तन्तु-निर्मित घना आच्छद, द्वितीय आवर्त से योनि-स्थित मांसपेशी-स्तर एवं तृतीय आवर्त से योनि की श्लेष्मल कला ग्रहण कर सकते हैं (चित्र १)।

(३) आवर्त शब्द को रचना का द्योतक मानकर भाग को प्रथम आवर्त, योनिनलिका को द्वितीय आवर्त एवं गर्भाशयादि को तृतीय आवर्त लिया जा सकता है।

(४) योनि की पूर्ण भित्ति में ३ संतकाय होते हैं^१ यथा एक द्वार के ठीक ऊपर या सबमिपटल सॅल्कॅस, दूसरा इससे लगभग ३५ मि. मी. ऊपर मूत्रनलिका एवं वलित के संयोग-स्थान-स्थित ट्रांसवर्स वैजिनल सॅल्कॅस और तीसरा वलित

१. शा. द्वारा लिखित टेक्स्टबुक आफ गाइनिकॉलॉजी, पृ. ५

के योनिनलिका की पूर्वीभित्ति से संयोग-स्थान-स्थित ब्लेंडर सॅल्कॅस। इन तीनों संतकाय को तीन आवर्त माना जा सकता है।

उपरि वर्णित नं. २ की व्याख्या अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होती है क्योंकि आचार्य डलहूष ने भी मुखाश्रित दो पेशियों की स्थिति की व्याख्या करते हुए आवर्तत्रय की स्थिति गर्भमार्ग में ही मानी है। इन्होंने आवर्तत्रय से गर्भशय्या को पृथक् माना है क्योंकि आवर्तत्रय गर्भमार्ग में होते हैं न कि गर्भशय्या में। टीकाकार इन्दु ने भी गर्भशय्या को तृतीय आवर्त में प्रतिबद्ध माना है (पृ. ७७), अर्थात् गर्भशय्या योनि के आवर्तों से पृथक् अङ्ग है।

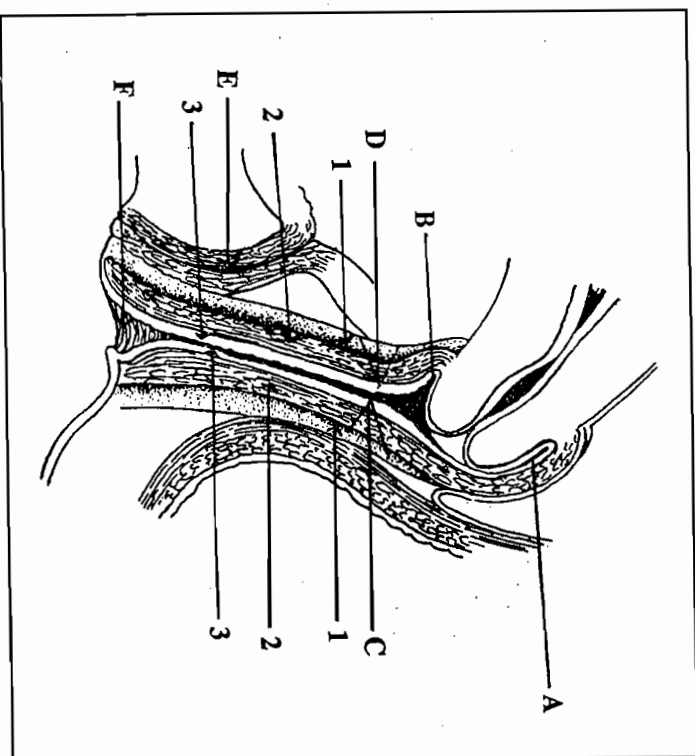


Fig. (1) : Showing *āvaras* of *yonī* and also *peṭīs* (muscles) in a cross section of vagina.

- | | | |
|---|------------------------|--|
| A. Posterior fornix, | B. Anterior fornix | |
| C. Posterior vaginal wall | | } Two muscles spreading inside the canal |
| D. Anterior vaginal wall | | |
| E. Urethra, | F. Introitus of vagina | |
| 1. Thick connective and fibrous layer separating vaginal canal from bladder and urethra anteriorly and rectum posteriorly | | } Three <i>āvaras</i> of <i>yonī</i> |
| 2. Muscular coat of vaginal canal | | |
| 3. Mucous membrane of vaginal canal | | |

१. गर्भिच्छर्माश्रिता इति गर्भमार्गाश्रितास्तिव आवर्तत्रयरूपेण, तृतीये चावर्ते मत्स्यमुखकाय गर्भशय्या (यत्र गर्भिस्त्वर्षति) (सु० सं० शा० ५/३९, डलहूष टीका)

The word *yoni* in *d̥yurVEDika* classics refers to entire reproductive system and also to individual organs separately. Its shape resembles the mid part of conchshell as it is narrow at the introitus and very wide at fornices. Its three *āvaras* are explained as vagina with its adnexal structures, cervix with adnexa and uterus with adnexa by Dr. Joshi, Dr. Ghāṇḍikāra takes these to be mucous membranous folds. Other few explanations can also be given for these three *āvaras* as (A) (i) introitus, (ii) mid canal and (iii) fornices; (B) (i) thick connective and fibrous layers separating vaginal canal from urinary bladder and urethra anteriorly and rectum and anus posteriorly, (ii) muscular layer and (iii) mucous membrane (fig. 1). (C) (i) external genitalia, (ii) vagina and (iii) uterus with adnexa. (D) (i) subneatal sulcus, (ii) transverse vaginal sulcus (iii) and bladder sulcus. Out of all these four explanations, number 'B' seems to be more logical because Dāhāṇa and Indu have accepted *garbhāśāyā* as separate from three *āvaras* and these *āvaras* are said to be situated in *garbhamaṅḍra* (vaginal canal).

गर्भाशय (Uterus)

स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टम इति । (सु० सं० शा० ५/८)

पित्तपक्वाशयोर्मध्ये गर्भाशया यत्र गर्भास्तिष्ठति ॥ (सु० सं० शा० ५/३९)

शङ्खनाभ्याकृतियौस्थित्वासां प्रकीर्तिता । तस्यास्तृतीये त्वावर्ते गर्भाशया प्रतिष्ठिता ॥

(सु० सं० शा० ५/४३)

यथा रोहितामृतस्य मुखं भवति रूपतः । तत्संस्थानां तथारूपां गर्भाशयां विदुर्बुधाः ॥

(सु० सं० शा० ५/४४ एवं प्रा० प्र० पूर्व ३/३२)

स्त्रीणाम्नां वस्तिपाश्र्वांगतो गर्भाशयः सन्निकृष्टः ॥ (सु० सं० चि० ७/३३)

स्त्रीणां पित्तपक्वाशयोर्मध्ये गर्भाशयोऽष्टमः ॥ (अ० सं० शा० ५/४६)

योनित्तु शङ्खनाभ्याकृतित्थित्वासां । तस्यास्तृतीय आवर्ते पित्तपक्वाशयान्तरे रोहितमृत्युमुखाकारा गर्भाशया ॥

(अ० सं० शा० ५/९९)

स्त्रीणां तु वस्तिः पाश्र्वांगतो गर्भाशयः सन्निकृष्टः ॥ (अ० सं० चि० ९/३२७)

गर्भाशयोऽष्टमः स्त्रीणां पित्तपक्वाशयान्तरे ॥ (अ० ह० शा० ३/१९)

तेषामप्यस्ताद्विपुलं स्त्रोतः कुण्डलसीस्थितम् । जरायुणा परीवीतं स गर्भाशय उच्यते ॥

(का० सं० शा० ३/६ व ७)

स्त्रिया गर्भाशयोऽष्टमः । (का० सं० शा० ३/९)

स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टमः ॥ (का० सं० चि० ९/१६)

स्त्रियों में पुष्टों की अपेक्षा एक आठवाँ आशय गर्भाशय अधिक होता है ।

यह गर्भाशय, शंखनाभ्याकृति योनि के तीसरे आवर्त में, पित्ताशय एवं पक्वाशय के मध्य स्थित, गर्भ का आधार होता है । अश्वमेदीचिकित्साध्याय में महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने इसकी स्थिति वस्ति के पार्श्व में वर्णित की है । यह रोहितमृत्यु-मुखवात् होता है । महर्षि काश्यप-भगवत्पुरा यह महाश्वेत की कुण्डलिकाओं के बीच जरायु से आच्छादित हो स्थित रहता है । आचार्य डल्हण ने रोहितमृत्यु के मुख से उस सदृश ही गर्भाशय की अभ्यन्तर सुषिरा का वर्णन है ।

१. गर्भाशयो गर्भाशयोऽष्टमः । पित्तपक्वाशयान्तरे-मध्य, पित्तपक्वाशयान्तरे तस्मिन् गर्भस्य आशयः ।

(अ० ह० शा० ३/१९ अस्यादत टीका)

क्रिया है^१, चिकित्साध्याय-वर्णित वस्ति के पार्श्व की स्थिति के स्पष्टीकरण में वैतण टीका का उद्धरण देते हुए लिखा है कि स्त्रियों में भग के नीचे (पीछे) वस्ति तथा ऊपर (वस्ति के ऊपर) गर्भाशय स्थित है । गर्भाशय एवं वस्ति महाश्वेतोत्स के आश्रित है ।^२ (चित्र २)

आचार्य भावमिश्र ने वर्णन में सु. सं. शा. ५/४६ का अन्वयः पालन करते हुए रोहितमृत्युमुखाकार देते हुए मृत्यु की जल के मध्य की स्थिति से ही गर्भाशय की पित्तपक्वाशयान्तरे-स्थिति की तुलना की है ।^३ अन्यत्र आशयोलेख

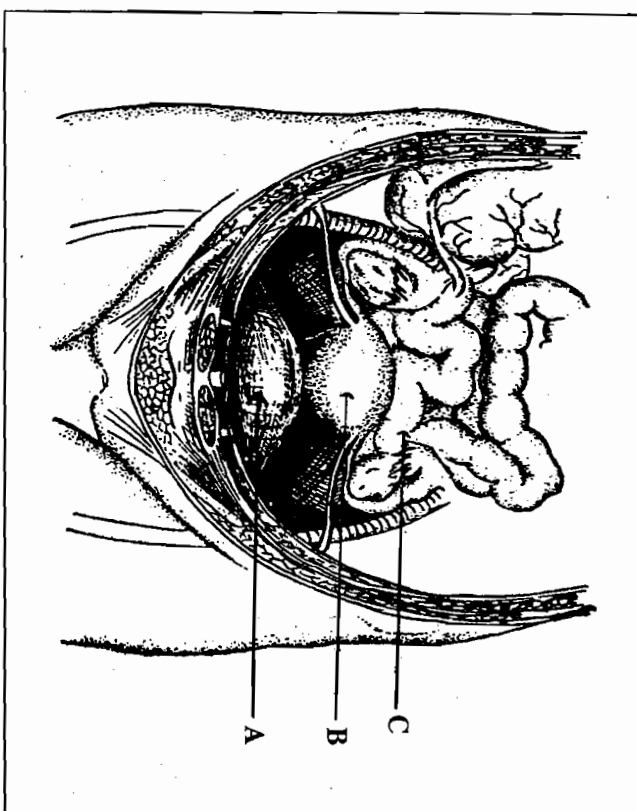


Fig. (2) : Showing situation of *garbhāśāyā* (uterus) behind the *basti* (urinary bladder) and inbetween *vipula kunda* of *strotas* (multiple coils of intestines).

A. Urinary bladder

B. Uterus

C. Coils of small intestine

१. तत्संस्थानामिति अल्पमुखापान्तर्महासुषिरामित्यर्थः । (सु० सं० शा० ५/४४ डल्हण टीका)

२. भागस्याधः स्त्रिया वस्तिर्लक्ष्यं गर्भाशयः स्थितः । गर्भाशयश्च वस्तिश्च महाश्वेतः समाश्रितौ ॥ (सु० सं० चि० ७/३३ डल्हण टीका)

३. (अ) स एव गर्भस्याधानं कुर्वाणशरीरे स्त्रियाः । (प्रा० प्र० पूर्व ३/८६)

(आ) अयमर्थः-गर्भशय्याया मुखं रोहितमृत्युमुखे भवति यथा च रोहितमृत्युस्य स्थितिर्वले भवति तथा पित्ताशयपक्वाशयोर्मध्ये गर्भाशयाः स्थितिर्भवति रूपमपि तस्यैव भवति यथा रोहितस्य मुखं स्वल्पमाशयस्तु महाश्वेतः ॥

(प्रा० प्र० पूर्व ३/३२)

में पित्ताशय एवं पक्वाशय के बीच स्थित "धरा" को गर्भाशय तथा प्रवृद्ध स्तनों को स्तन्याशय की संज्ञा दी है।^१ महर्षि शार्ङ्गधर ने भी शब्दभेद से यही वर्णन दिया है।^२ अष्टाङ्गहृदय में कोष्ठाङ्गों के अन्तर्गत हिप्प का उल्लेख है। टीकाकार अरुणरत्न ने इसे रक्त एवं मांस के प्रसार से निर्मित तथा आन्त-सम्भव वर्णित किया है।^३

Women possess one extra eighth *āśya* as *garbhāśya*, which is situated in third *avara* of *yoni*, behind the urinary bladder, in between *pitāśya* and *pakvāśya*; or in between '*uipula kundala of strotas*' (multiple coils of intestine), covered with *jaryū* (peritoneum). It resembles mouth of *rohita* fish (fig. 2). Dalhana says that it is hollow inside just like mouth of *rohita* fish; the *vasti* (urinary bladder) is behind the *bhaga* (vulva) and uterus is above this. Vāgbhata II has enumerated *dimbha* amongst the structures of *kośha*, *Arunadatta* says that it is made from essence of *rakta* and *mānasa* and is derived from intestines.

विमर्श (Comments)

गर्भाशय की तुलना रोहित-मत्स्य-मुख से सम्भवतः दो कारणों से की गई हो। (१) अकृति में सामञ्जस्य - क्योंकि दोनों का ही आकार त्रिकोणकार सा होता है, एवं आप्यन्तर सुषिरता होती है, मुख नीचे चपटा तथा ऊपर उन्नतोर होता है इसी प्रकार गर्भाशय की अग्रिम भित्ति कुछ चपटी तथा पश्चिम भित्ति किञ्चित् उन्नतोर होती है। (२) इस मत्स्य के ओष्ठ मांस-निर्मित मोटे लटके हुए से होते हैं, इनके ठीक पीछे दन्त-पंक्ति न होकर यह कुछ अन्दर की ओर होती है। ये गोल, लटकते हुए से मृदु ओष्ठ गर्भाशय-ग्रीवा से सामञ्जस्य रखते हैं।^४

पित्ताशय एवं पक्वाशय के मध्य गर्भाशय की स्थिति एक विवाद का विषय बना हुआ है। यदि पित्ताशय से आधुनिक मान्यता प्राप्त अंग गालब्लेडर लिया जाय तो गर्भाशय की स्थिति स्पष्ट करने में कठिनाई होगी, क्योंकि इस अंग के निकट गर्भाशय केवल गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में ही पहुँच पाता है। अतः यहाँ पर पित्ताशय से पित्तधरा कला जिसका स्थान ग्रहणी (हृद्रात्रि) है, लेना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस कला का पित्तधरा नाम ही इसके पित्त के आशय या स्थान होने का द्योतक है। पक्वाशय शब्द बृहदात्रि एवं मलाशय के लिए प्रयुक्त होता है। टीकाकार अरुणरत्न ने पुरीषला प्राप्त अन्न के स्थान को पक्वाशय माना है।^५ इस अर्थ से गर्भाशय की स्थिति सुस्पष्ट हो जाती है कि यह आशय बसित के पार्श्व (पश्चिम पार्श्व) या बसित एवं मलाशय के बीच (श्रोणिगुहा) में स्थित रहता है एवं पित्तधरा कला के स्थान धुरात्रा की कुण्डलिकाएँ इसके ऊपर रहती हैं जो गर्भाशय-भेदनादि उपद्रव होने पर गर्भाशय गुहा में भी प्रवेश कर जाती हैं। काशयपसंहिता में यह स्थिति और भी सुस्पष्ट है क्योंकि यह अंग कुण्डलिकाओं के मध्य स्थित वर्णित है एवं इसकी पूर्व तथा पश्चिम भित्तियाँ उदर्याकला द्वारा आच्छादित रहती हैं।^६

१. पुरवेष्ट्योऽधिकाश्चान्ये नारीणामाशयादयः। धरा गर्भाशयः प्रोक्तः पित्तपक्वाशयान्तरे। स्तनौ प्रवृद्धौ तवेव बूधैः स्तन्याशयौ मतौ। (भा० प्र० पूर्व० ३/२९७, २९८)
२. पुरवेष्ट्योऽधिकाश्चान्ये नारीणामाशयादयः। धरा गर्भाशयः प्रोक्तः स्तनौ स्तन्याशयौ मतौ। (शा० सं० पूर्व० ५/१०)
३. कोष्ठाङ्गानि स्थितायेषु हृदयं क्लीम पुण्डसम्। यक्ष्णीहीनदुक्तं वृक्षौ नाभिद्विभ्यान्वबस्यतः॥ (हिप्पं स्यात्कर्मसंस्था प्रसादादान्नसम्भवः - अरुणरत्नः) (हिन्व-पाटटीका) (अ० ह० शा० ३/१२)
४. तथा पक्वाशयस्य पुरीषला प्राप्तस्य य आशयः स पक्वाशब्देनोच्यते॥ (अ० ह० शा० ३/१९ अरण्य० टीका)
५. संस्कृत-व्याकरण दृष्ट्या काशय-वर्णित श्लोक अशुद्ध सा प्रतीत होता है, क्योंकि गर्भाशय पुष्पिंश शब्द के सभी विशेषण नपुंसकलिंग में वर्णित हैं, जिसके कारण ही कतिपय विद्वानों ने कुण्डलिकाचक्र-स्थित-स्रोत ऐसा वर्णन किया है। गर्भाशय स्रोत न होकर आशय है, पाठान्तर्गतों में तनिक अशुद्धि का आ जाना असम्भव नहीं कहा जा सकता, अतः आचार्य त्रिपयस्र शर्मा जी के मतानुसार श्लोक का निम्न पाठ अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है -

तेषामप्यस्ताद्विगुलस्स्रोतस्कुण्डलसंस्थितः। जरायुणा परिवर्तितः स गर्भाशय उच्यते॥

अष्टाङ्गहृदय वर्णित हिप्प या हिन्व शब्द सम्प्रति स्त्रीबीज के लिए प्रयुक्त होता है। अङ्ग के अन्य वर्णन की अनुपस्थिति तथा स्त्री एवं पुरुष में समान रूप से उपस्थिति, इसके किसी भी रचना से सामञ्जस्य में कठिनाई उत्पन्न करती है। हिन्व शब्द से अमरकोष (२/५३८) में बालक तथा वैद्यक शब्दसिन्धु में मूत्राशय एवं गर्भाशय अर्थ ग्रहण किया गया है। गर्भाशय मांस निर्मित एवं रक्तधियुक्त अङ्ग है तथा आन्तों के बीच में रहता है अतः स्त्री-शरीर-दृष्ट्या इससे गर्भाशय अर्थ लिया जा सकता है।

The simile of uterus with mouth of *rohita* fish might have been given probably due to two reasons i.e. (1) similarity in shape, as both are triangular and hollow inside; the mouth of fish is flat below and slightly convex above, similarly anterior wall of uterus is slightly flat, while posterior wall is slightly convex. (2) the lips of fish are fleshy and hanging, teeth are not just behind the lips, rather situated slightly behind these giving appearance of a rounded soft structure, which resembles cervix of uterus.

In the context of situation of uterus the word *pitāśya* should not be considered as gallbladder, rather it should be taken as small intestine, the seat of *pitādhara kalā*, *pakvāśya* refers to the place of digested food i.e. large bowel. The uterus is above sigmoid colon, behind the urinary bladder and multiple coils of small bowel rest upon uterus, it is covered with peritoneum and is an intrabdominal structure, which has been mentioned by Kāśyapa and Dalhana.

The word *dimbha* is not clear, presently it is used to denote ovum. Due to absence of specific structural description and its presence in male and female both, it is difficult to equate it with any structure. In *Amarakosa* it is translated as child, while *Vaidyaka Śabdāsindhu* book explains it as urinary bladder or uterus, thus, in context of females this can be considered as uterus as it is made up of flesh, is good vascular and is situated amongst the intestines.

आशयन्तर स्रोतस् या आर्तववह स्रोतस् (Ārtava vaha strotas)

आर्तववहे द्वे, तयोर्मूलं गर्भाशय आर्तववाहि-व्यञ्ज धमन्यः;

तत्र विद्वायां वन्यात्वं मैथुनासहिष्णुत्वमार्तवनाशश्च। (सु० सं० शा० ९/१२)

आर्तववह स्रोतस् दो होते हैं, इनके मूल गर्भाशय एवं आर्तववाही धमनियों में होते हैं। इनका वेध होने पर वन्यात्व, मैथुनासहिष्णुत्व एवं आर्तवनाश लक्षण होते हैं।

These are two in number, having roots in *garbhāśya* and *ārtavavāhī dhmanās*, injury to these produces infertility, dyspareunia and amenorrhoea.

विमर्श (Comments)

आचार्यों ने शरीर में बहिर्मुख एवं अन्तर्मुख दो प्रकार के स्रोतसों का वर्णन किया है। बहिर्मुख स्रोतसों में स्तन्यवाही दो एवं रजोवाही एक वर्णित है। रजोवाही बहिर्मुख स्रोतस् का वर्णन पूर्वपुष्टों में आ चुका है। आप्यन्तर स्रोतस् वे सुषिर नलिकाएँ हैं जिनके मुख हमें सामान्य रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते। स्त्री-शरीर-स्थित विशिष्ट आप्यन्तर स्रोतसों का वर्णन केवल महर्षि सुश्रुत ने किया है। अन्य आचार्यों ने शुक्रवह स्रोतस् के समकक्ष स्त्री-शरीर में स्तन्यवह स्रोतस् माना है जिसका वर्णन यथास्थान किया जायगा।

इन अर्तवह सोतसों के आधुनिक विज्ञान में वर्णित अंगों से सामंजस्य के बारे में विद्वानों में मतभेद है। पींडित गंगाधर जोशी ने इन्हें गर्भाशयान्तर स्थित स्तेष्मल कला माना है।^१ जिस मान्यता को प्रमाणित करने के लिए आधारभूत-दृष्टान्त में गर्भाशया के समय अर्तवह सोतस के मुख का अवरोध हो अनर्तव होना दिया है। गर्भावस्थावन्त सोतसमुख-अवरोध-वर्णन एवं सोतोवेध में अनर्तव की उत्पत्ति आदि उद्धरणों को दृष्टिगोचर करते हुए आचार्य घणोकर ने इन्हें गर्भाशयिक धमनियाँ माना है।^२ डॉ० फि० ग० जोशी ने अर्तवह सोतस में डिम्बग्रन्थि, डिम्बप्रणाली एवं उनकी रक्तवाहिनियों का समावेश किया है।^३

गर्भाशयान्तःकला संख्या में एक तथा डिम्बप्रणाली एवं डिम्बग्रन्थियाँ मिलकर चार हो जाती हैं, जब कि अर्तवह सोतसों की संख्या दो हो बटाई गई है, अतः ये वर्णन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते एवं आचार्य घणोकर का विचार ही अधिक मान्य प्रतीत होता है। संहिताओं में अर्तवहोमोचनी धमनियों का वर्णन है, जो गर्भाशयिक धमनियाँ मानी जा सकती हैं (धमनी वर्णन में स्पष्ट किया जायगा), अतः यदि ये दोनों धमनियाँ एवं गर्भाशय अर्तवहस्रोतस के मूल मान लिए जाएँ तो वेध से उत्पन्न सभी लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यदि ये गर्भाशयिक धमनियाँ विद्ध हो जायें तो गर्भाशयान्तःकला का पोषण न होकर अनर्तव एवं बन्ध्यात्व हो जाएगा, साथ ही वेधजन्य उत्पन्न शोथदि एवं अनर्तवजन्य मानसिक विकार से भैशुनासहिष्णुता भी उत्पन्न हो जायगी।

These may be considered as uterine arteries, specially their capillary bed, because these arteries are responsible to carry *āraava* (*āraavavāhī dhamaṇī*), are two in number, have attachment with uterus and injury to these vessels may result in infertility and amenorrhoea due to absence of proper blood supply to uterus alongwith endometrium, dyspareunia may also occur due to associated inflammation caused during injury and psychological upset due to amenorrhoea etc.

धमनी (Arteries or channels)

(अ) ऊर्ध्वग धमनी (Arteries or channels tending upwards)

द्वे सत्यं स्त्रिया वहतः स्तनसीध्रते, ते एव शुक्रं नरस्य स्तनाभ्यामभिवाहतः। (सु० सं० शा० ९/५)
द्वे च स्तनाध्रते नायाः सत्यं नरस्य शुक्रम्। (अ० सं० शा० ६/३९)

स्त्रियों के स्तनों में सत्य का वहन करने के लिए दो धमनियाँ होती हैं। वे ही पुरुषों में (स्तन से सुश्रुत मलानुसार) शुक्र का वहन करती हैं।

Women possess two *dhamanīs* to carry *stanya* (milk) to the breasts, analogous to those carry *śukra* in males.

(आ) अधोगामी धमनियाँ (Arteries or channels tending downwards)

अधोगमास्तु—आर्तवादीन्यधो वहन्ति।—शुक्रवहे द्वे शुक्रप्रदुर्भावाय, द्वे विसर्गाय, ते एव रक्तमभिवाहतो नारीणामर्तवसंज्ञम्। (सु० सं० शा० ९/७)

द्वे शुक्र वहन्तो द्वे च मुञ्चतः। ते एव नारीणामर्तवम्। (अ० सं० शा० ६/३२)

१. सु.सं.शा. ९/१२ घणोकर टीका, पृष्ठ २२९
२. सु.सं.शा. ९/१२ घणोकर टीका, पृष्ठ २२९
३. आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स इन गाइनिकॉलॉजी, वि. ग. जोशी।

आर्तवादि को नीचे की ओर वहन करनेवाली अधोगामी धमनियाँ होती हैं।

पुरुषों में शुक्रप्रदुर्भावा (सुश्रुत) या शुक्रवहन (वाण्ट) के लिए दो एवं शुक्र विसर्ग के लिए दो इस प्रकार चार धमनियाँ होती हैं। वे ही स्त्रियों में रक्त के अभिवहन के लिए (दो प्रदुर्भावा या वहन के लिए एवं दो विसर्ग के लिए) होती हैं।

Channels tending downwards carry *āraava* etc. downwards.

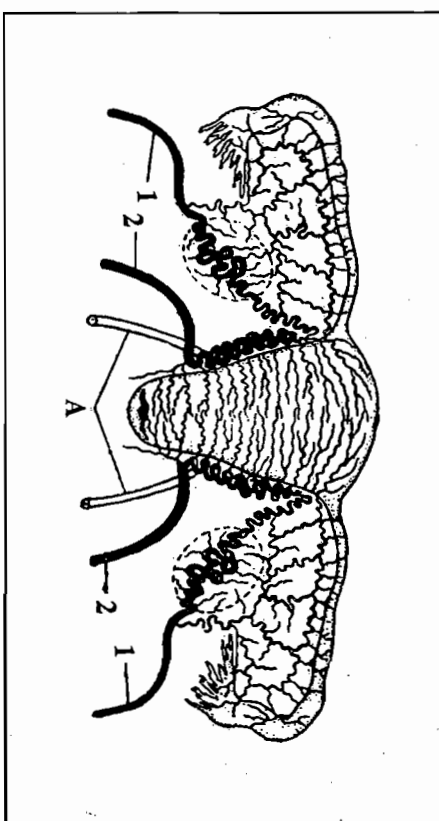
Males have two *dhamanīs* (arteries) for formation of *śukra* (semen) and two for its excretion. Analogous to these carry *āraava* in females.

विमर्श (Comments)

संहिताओं में वर्णित धमनी शब्द विवादास्पद है, कुछ विद्वान इस शब्द से शुद्ध रक्तवाही नलिकाएँ एवं कुछ नाड़ियाँ ग्रहण करते हैं। आचार्य घणोकर ने स्तन्यवह धमनी से भैमरी आर्टरी ग्रहण किया है। आधुनिक शरीर रचना या क्रिया-विज्ञान दृष्ट्या इनका शुक्र से कोई सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन है। पींडित गंगाधर शास्त्री ने इनके समकक्ष किसी भी नाड़ी का वर्णन नहीं किया।

डॉ० घणोकर ने अर्तव वहन एवं विमोचन करने वाली धमनियों को यूटीरिन तथा ओवैरिन वैसेल माना है। पींडित

Fig. (3) : Showing *adhogā dhamanīs* (channels tending downwards).



- A. Uterus
1. Ovarian arteries (*āraavavāhī dhamaṇīs*).
2. Uterine arteries (*āraavavimocinī dhamaṇīs*).

गंगाधर शास्त्री इनसे हाइपोगैस्ट्रिक एवं ओवैरिन नर्वोइन प्लेक्सस ग्रहण करते हैं। आचार्य घणोकर का मत अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि अर्तव निर्माण एवं विसर्ग में नाड़ियों का उतना प्रभाव न होकर रक्तसंवहन या धमनियों का ही अधिक प्रभाव होता है, अतः अर्तव प्रदुर्भावा या वहन एवं विसर्जन की धमनियों से क्रमशः ओवैरिन एवं यूटीरिन आर्टरी ले सकते हैं (चित्र ३)।

Arteries tending upwards may be considered as mammary arteries and those of downwards as ovarian arteries (responsible for formation of *artava* i.e. ovum and/or ovarian hormones) and uterine arteries (responsible for excretion of *artava* or menstrual blood) (fig. 3).

शिराएँ (Veins)

स्त्री-शरीर-स्थित विशिष्ट शिराओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अवेध्य शिराओं में आचार्य सुश्रुत ने शा० ७/१९-२२ में स्तनमूल में स्थित २-२ अर्थात् चार शिराओं को अवेध्य माना है जो आचार्य णोकर के मत से इन्टर्नेल मैमरी वेन्स मानी जा सकती हैं।

Suśruta has described two veins situated in root of each breast not suitable for venesection. These may be considered as internal mammary veins.

मर्म (Vital parts)

स्तनों में स्तनरोहित एवं स्तनमूल दोनों २-२ यानी चार मर्मों का वर्णन है^१, इनमें स्तनरोहित मांस मर्म तथा स्तनमूल शिरा मर्म^२ हैं। ये चारों ही कलान्तर प्राणहर मर्म हैं^३। दोनों स्तनों में दो अङ्गुल नीचे स्तनमूल नामक मर्म होते हैं, जिनके विद्वद् होने पर कोष्ठ कफ से भर कर कासश्वास से मृत्यु होती है; दोनों स्तनचूषकों के दो अङ्गुल ऊपर स्तनरोहित नामक मर्म हैं, वहाँ पर वेध होने से कोष्ठ रक्त से पूर्ण हो कास-श्वास से मृत्यु होती है। स्तनमूल मर्म २ अङ्गुल एवं अन्य (स्तनरोहित) आधे अङ्गुल के होते हैं^४।

अभ्यरीविक्रान्ता-वर्णन में महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने निर्भाङ्कित वर्णित आठ मर्मस्थानों को आघात से सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

मूत्रवहशुक्रवहमुष्कस्रोतोमूत्रप्रसेकसेवनीयोनिगुदवस्तीनाष्टौ परिहेत् । (सु० सं० चि० ७/३६)

सेवनी शुक्रहरणी स्रोतसी फलयोर्गुदम् । मूत्रसेकं मूत्रवहं योनिर्विस्तस्यष्टाष्टमः ॥

(सु० सं० चि० ७/३८)

कर्मणि तु मूत्रवहशुक्रवहमुष्कस्रोतोमूत्रप्रसेकसेवनीयोनिगुदवस्तीनाष्टौ परिहर्तव्याः ॥

(अ० सं० चि० १३/३२)

मूत्रवह, शुक्रवह, मुष्कस्रोत, मूत्रप्रसेक, सेवनी, योनि, गुदा तथा बस्ति का परिहार करना चाहिये। गद्य में मुष्कस्रोत एवं पद्य में “स्रोतसीफलतयोः” शब्द का प्रयोग हुआ है जो एक दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं। ऐसा आभास होता है कि शुभ्र अंगों को (शुक्रवह एवं मुष्कवह स्रोतस्-दो-दो होते हैं) गद्य में एकवचन में ही वर्णित किया गया है परन्तु पद्य में ‘द्विवचन’ में। “शुक्रहरणी” शब्द स्त्रीलिंग होने से युक्तिसंगत न हो ‘शुक्रहरणे’ द्विवचन शब्द उचित प्रतीत होता है। “स्रोतसीफलतयोः” या “मुष्कस्रोतस्” का संख्यागणन शरीरस्थान अध्याय ९ वर्णित स्रोतसों में नहीं किया गया। मुष्क

१. सु० सं० शा० ६/६; अ० सं० शा० ७/१२, १३
२. सु० सं० शा० ६/७; अ० सं० शा० ७/२९
३. सु० सं० शा० ६/१०; अ० सं० शा० ७/३० (२)
४. सु० सं० शा० ६/२५; अ० सं० शा० ७/१२, १३
५. सु० सं० शा० ६/२८, २९

(स्क्रोटम या टेस्टीज) के समकक्ष स्त्री में डिम्बग्रन्थि (ओवरी) ले सकते हैं क्योंकि वे भी दो ही होती हैं। वाग्भट ने मूत्रवह, शुक्रवह, मुष्कस्रोत, मूत्र (प्रसेक), सेवनी, योनि, गुद एवं बस्ति आठ मर्मों का परिहार करने का निर्देश दिया है।

मर्म क्या है ? आधुनिक शरीर-रचना-विज्ञान-वर्णित किसी भी एक अंग से मर्म का सामंजस्य स्थापित करना कठिन सा प्रतीत होता है। ये ऐसे स्थान हैं जिनमें आघात लगने पर व्यक्ति की मृत्यु (सद्यःप्राणहर या कलान्तर प्राणहर या विशाल्प्यध), अत्यधिक पीड़ा (रुजाकर) या स्थायी विकृति (वैकल्यकर) उत्पन्न होती है। अतः इन्हें वाइटल पार्ट्स कह सकते हैं।

उपरोक्त वर्णित मर्मों में गुद एवं बस्ति को छोड़कर अन्य किसी भी मर्म का नामोल्लेख सु०सं० शरीरस्थान ६ एवं अ०सं०शा०७ में मर्म-संख्या-गणना में नहीं किया गया। संभवतः इन अंगों का महत्त्व अश्मनी-निर्हरण के लिए किये गए शल्यकर्म के ही समय होता हो, अतः यहाँ वर्णित किये गए हैं। स्त्री-शरीर-दृष्ट्या इन मर्मों में से निर्भाङ्कित मर्म अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

- (१) सेवनी (२) योनि (३) फलस्रोतस् (४) मूत्रप्रसेक (५) गुदा (६) बस्ति (७) मूत्रवह
सेवनी

सेवनीयोन्येदनाद्रुजाप्रादुर्भावः ॥ (सु० सं० शा० ९/१२)

सेवनीयोन्येदनाद्रुजाप्रादुर्भावः ॥ (अ० सं० चि० १३/३२)

सेवनी के छेदन होने से रुजा या वेदना का प्रादुर्भाव होता है।

सेवनी स्त्री पुरुष दोनों में ही समान रूप से वर्णित है। यह वर्णन पेरीनियल रेफी को इंगित करता है।

योनि

सेवनीयोन्येदनाद्रुजः प्रादुर्भावः । (सु० सं० चि० ७/३६)

सेवनीयोन्येदनाद्रुजाप्रादुर्भावः ॥ (अ० सं० चि० १३/३२)

सेवनी सदृश योनिच्छेद से भी रुजा का प्रादुर्भाव होता है।

योनि शब्द से योनिनालिका के ही साथ सदृशानुसार समस्त स्त्रीजननांग का भी ग्रहण किया जाता है एवं इनके आघात या छेदन होने पर विभिन्न प्रकार के विकार या वेदनाएँ हो सकती हैं।

फलस्रोतस्

द्विवचन शब्द के प्रयोग के कारण एवं पुरुष के मुष्क (टेस्टीज) के समकक्ष स्त्री में डिम्बग्रन्थि होने से यहाँ फल शब्द से डिम्बग्रन्थि का बोध होता है, यद्यपि इनके छेदन के स्पष्ट लक्षणों का कहीं निर्देश नहीं है, पर यदि ये दोनों विद्वद् हो जाँय (नष्ट हो जाँय) तो अनातर्व, बन्ध्यात्व आदि लक्षण हो सकते हैं।

मूत्रप्रसेक

मूत्रप्रसेकक्षणानामूत्र प्रक्षरणं ॥ (क्षणनात् छेदनात्, मूत्रक्षरणं मूत्रस्रवणं-उल्लाप ॥)

(सु० सं० चि० ७/३६)

मूत्रप्रसेकच्छेदनामूत्रस्रवणम् ॥ (अ० सं० चि० १३/३२)

मूत्रप्रसेक के छेदन से मूत्र का स्राव होता रहता है।

गुद एवं वसि

ये दोनो ही मांसमर्म,^१ हृष्य की हथेली की बगल की आकृति^२ के एवं सद्यःआणहर मर्म^३ हैं। वसि मूत्राशय को कहते हैं। अशमरी-विकसिता के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से इसमें दोनों ओर छिद्र होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है, एक ओर छेदन होने से मूत्रस्रावी व्रण बन जाता है जो बहुत प्रयत्न करने पर ही ठीक होता है।^४

मूत्रवह

मूत्रवह मर्म का छेदन होने से वसि मूत्र से पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु हो जाती है।^५

मूत्र का वहन गवीनियों से मूत्राशय (वसि) की ओर होकर एकत्र होने के बाद मूत्र का स्रवण मूत्रप्रसेक से होता है, परन्तु गवीनी संख्या में दो होती हैं एवं यहाँ मूत्रवह शब्द का प्रयोग एकवचन में है। गवीनियों का वेधन होने से वसि के पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता अतः यदि यहाँ मूत्रवह शब्द से मूत्रनलिका का अप्यन्तर मुख ग्रहण करें तथा वेधन से आघात हो कर अवरोध होना मान ले तो वसि की पूर्णता सिद्ध हो सकती है।

संहिताओं में स्त्रियों के गर्भाशय की वसि-पाश्र्व-स्थिति वर्णित कर उनमें अशमरी-निर्दोषार्थं उत्सङ्गवत् शस्त्र-पातन निर्दिष्ट किया है क्योंकि ऐसा नहीं करने से उनमें मूत्रस्रावी व्रण बन सकता है।^६ टीकाकार डल्हन ने स्पष्ट किया है कि यदि उत्सङ्गवत् अर्थात् उत्तान शस्त्रपात न कर, अर्थात् शस्त्रपात किया गया तो बहिर्गता त्वचा तथा मांस का भेदन हो वसित्वचा के साथ भागवत् एवं वसि-पाश्र्व में आश्रित होने के कारण गर्भाशय की भी त्वचा का भेदन हो जाता है जिससे भगान्तरात् मूत्रस्रावी व्रण बन जाता है।^७ टीका में गर्भाशयद्वार का छेदन हो मूत्रस्रावी व्रण निर्मित के साथ योनि में भी व्रण हो स्राव होने का वर्णन है।^८ यद्यपि प्राग्भ में मूत्रप्रसेक में आघात होने से केवल पुरुषों में मूत्रशय होने का उल्लेख है, परन्तु इसी सन्दर्भ में आगे ऐसा कोई भी लिङ्ग-भेद वर्णित नहीं है।^९ मूत्रप्रसेक मर्म मूत्रवही नलिका का द्योतक है

१. सु० सं० शा० ६/७; अ० सं० शा० ७/२९
२. सु० सं० शा० ६/२९; अ० सं० शा० ७/३३
३. सु० सं० शा० ६/९, २५; अ० सं० शा० ७/३०(१); अ० सं० चि० १३/३२
४. सु० सं० शा० ६/२५; सु० सं० चि० ७/३३; अ० सं० शा० ७/८, ९
५. सु० सं० चि० ७/३६; अ० सं० चि० १३/३२
६. (अ) स्त्रीणां तु वसिपाश्र्वगतो गर्भाशयः सजिह्वः, तस्मात्तासांमुत्सङ्गवच्छ्रवणं पातयेत् अतोऽप्यथा खल्व्वासा मूत्रस्रावी व्रणो भवेत् ॥ (सु० सं० चि० ७/३३)
- (आ) स्त्रीणां - उत्सङ्गवदधः शस्त्रं पातयेत्। व्रणो भवति ॥ (सु० सं० सद्भा) (अ० सं० चि० १३/२७)
७. उत्सङ्गवत् उत्तानमित्यर्थः। अन्यथेऽति यदाऽप्यथाः शस्त्रपातः स्यात्तदा बहिर्गते त्वङ्मांसं भिन्ना वसित्वचा सह भागवत्सुवसिपाश्र्वस्य गर्भाशयस्यापि त्वचो भेदः स्यात्। ततस्तासां भगान्तरात् मूत्रस्रावी व्रणः स्यादित्यर्थः ॥ (सु० सं० चि० ७/३३ की डल्ह० टीका)
८. ... गर्भाशयस्य तद्वद्भास्य च च्छेदभयादित्यङ्गत्वात्...। ... मूत्रस्रावी व्रणोऽप्यथा प्रकारो भवेत् योनिषण्णोऽप्यमुखप्रवृत्तावित्यतिरिक्तं हृदयम् ॥ (सु० सं० चि० ७/३३ की चौ०ओ० द्वारा प्रकाशित पुस्तक की टीका)
९. (अ) पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेकशयनान्मूत्रशयणम्। (सु० सं० चि० ७/३३)
- (आ) ... मूत्रस्रावी व्रणो भवति पुरुषस्य च मूत्रप्रसेकशयनम्। (अ० सं० चि० १३/२७)
१०. (अ) मूत्रप्रसेकशयनान्मूत्रशयणम् ॥ (सु० सं० चि० ७/३६)
- (आ) मूत्रप्रसेकच्छेदाम्मूत्रवहणम् ॥ (अ० सं० चि० १३/३२)

जो स्त्री एवं पुरुष दोनों में ही समान रूप से विद्यमान होती है, जिसका स्पष्ट निर्देश टीकाकार डल्हन ने किया है।^१ पूर्ववर्णित वसित्वचा या गर्भाशयत्वचा में त्वचा शब्द अङ्ग के ऊपरी भाग के लिए उपलक्षण में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। वसि के साथ गर्भाशय अथवा गर्भाशयद्वार का छेदन होने से वसि-गर्भाशयागत मूत्रस्रावी व्रण (वेजिको यूटेरिन फिस्ट्यूल); वसि तथा योनि में आघात होने पर वसि-योनिगत मूत्रस्रावी व्रण (वेजिको वेजिनल फिस्ट्यूल) तथा मूत्र-प्रसेक अर्थात् मूत्रनलिका तथा योनि में आघात होने पर मूत्रनलिका-योनिगत मूत्रस्रावी व्रण (यूथ्रा वेजिनल फिस्ट्यूल) बन जाने की सम्भावना होती है।

गवीनी, मूत्रप्रसेक, गुद तथा वसि आदि अंगों का महत्व स्त्रीरोग सम्बन्धित सभी शल्यकर्मों में अत्यधिक होता है विशेषकर जहाँ गर्भाशय या योनिनलिका में शल्यकर्म किया जाय क्योंकि असंवधानी से किया गया शल्यकर्म इन अंगों के स्रावी व्रणों (फिस्ट्यूल) का निर्माण कर सकता है।

In breasts four *mammās*, two called *stanarohita*, the *māṃsa marmā* of $\frac{1}{2}$ *angula* size situated above the nipples on both the sides, and two termed *stanamūla*, the *śirā marmās* of $\frac{2}{2}$ *angula* size situated below both the breasts are present. All these cause death after some times, thus are called *kālanaraprāṇahara*. Death occurs by cough and dyspnoea due to filling of *koṣṭha* (chest cage) by *kapha* or *rakta* as a result of injury to *stanamūla* or *stanarohita marmā* respectively.

In the chapter of treatment of urinary bladder-stone, Suśruta and Vagbhata I have cautioned to avoid injury to eight vital parts i.e. *mūravaha*, *śukravaha*, *mūṣkastrots* or *phalastrots*, *mūtrapraseka*, *sevanī*, *yoni*, *guda* and *basti*.

Amongst these *sevanī*, *yoni*, *phalastrots*, *mūtrapraseka*, *guda*, *basti* and *mūravaha* etc. seven are important for females. Out of these only *guda* and *vasti* have been included in the enumeration of *marmās*, it is possible that others are important only during extraction of stone.

Sevanī and yoni

Sevanī refers to perineal raphe, while *yoni* to entire reproductive system also besides vaginal canal; injury to these causes pain.

Phalastrots

Phalastrots refer to ovaries of females, which are counterpart of testicles of males. Though specific symptoms of injury to these are not described in classics, however, injury to both these may cause amenorrhoea, infertility etc.

Mūtrapraseka

This refers to urethra. Injury to this causes flow (continuous) of urine.

१. इदानीमुपयोगी स्त्रीपुरुषोपादकारेण सामान्यं मूत्रस्राविणं व्रणं निर्दिशन्तः-पुरुषस्येत्यदि पुरुषस्य वेति वा शब्दद्वयं, तेन स्त्रियाः पुरुषस्य चेत्यर्थः। मूत्रप्रसेकस्रोतसी स्त्रीपुरुषयोः, अपभेदनीकत्वात्। मूत्रप्रसेको नाम मूत्रं येन वसिमुखश्रेण्येण स्रोतसां क्षतिः, तस्य छेदनादित्यर्थः॥ (सु० सं० चि० ७/३३ की डल्ह० टीका)

Guda and basti

Guda refers to rectum and *basti* to urinary bladder. These both are *manasa marmas* of the size equal to palm, and cause immediate death, if injured.

Mūtravāha

Injury to this produces fullness of urinary bladder followed by death.

Generally with *mūtravāha* ureters should be considered, because these fill the bladder with urine, however, these are two in number, while word *mūtravāha* is a word of singular number and injury to these can never cause fullness (retention of urine) of bladder, rather the bladder will remain empty, if it is taken as internal urethral meatus, it can explain the fullness of bladder, as its injury may prevent excretion of urine, thus bladder may become full.

In classics after describing the location of uterus behind the basti, it is advised that for extracting the urinary bladder-stone in the females, the instrument should be passed directing it upwards, or else an ulcer discharging urine may be formed. Dalhana says that if the instrument is inserted forcefully, deeper and directing it downwards instead of upwards, then, after puncturing the external skin and flesh, it will puncture the bladder, *bhaga* (vagina) and the uterus, situated behind the bladder, thus produce a wound discharging urine inside the *bhaga* (vagina). Besides injury to the orifice of uterus, the vagina is also injured. Though initially continuous discharge of urine due to injury to *mūtravārasaka* of only males is described, however lateron in this very context the sex differentiation has disappeared. *Mūtravārasaka marmā* refers to urethra which is present in male and females both. Injury to the bladder with uterus or vagina results in development of utero-vesical or vesico-vaginal fistula respectively and injury to the urethra with vagina to urethro-vaginal fistula.

Besides, above structures others i. e. ureters, urinary bladder, urethra, rectum and anus have to be taken special care during any gynecological surgery, as injury to these may produce fistula.

पेयि (Pēṣṭis or muscles)

स्त्रीणां तु विंशतिरधिकः। दश तासां स्तनयोरैकस्मिन् पञ्च पञ्चेति, यौवने तासां परिवृद्धिः, अपत्यपथे चतस्रः-तासां प्रसूते अग्र्यन्तरतो दे, मुखाश्रिते बाह्वे च वृते दे, गर्भिच्छ्रुसंश्रितास्तिष्ठः। शुक्रार्तवप्रवेशिन्यस्तिष्ठ एव।

(सु० सं० शा० ५/३९)

स्त्रीणां तु विंशतिरधिका। तत्र दश स्तनयोः तासां यौवने परिवृद्धिर्भवति। दश योनौ। तत्सामभ्यन्तराश्रिते द्वे मुखाश्रिते वृते दे। तिस्रो गर्भमार्गाश्रयाः। यस्यां गर्भस्तिष्ठति-गर्भशय्या। तस्यां शुक्रार्तवप्रवेशिन्यस्तिष्ठः पेयः।

(अ० सं० शा० ५/९०, ९१)

पुंसां पेयः पुरस्तादाः प्रोक्ता लक्षणमुष्कजाः। स्त्रीणामावृत्य तिष्ठन्ति फलमन्तर्गतं हि ताः॥

(सु०सं०शा० ५/४९ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/१४७-लक्षण के स्थान पर मेहन शब्द)

स्त्रियों के शरीर में बीस पेशियाँ अधिक होती हैं, जिनमें दस में से एक-एक स्तन में पाँच-पाँच, जिनकी यौवन

में वृद्धि होती है। अपत्यपथ में चार, जिनमें आप्यन्तर प्रसृत दो तथा मुखाश्रित बाहर की ओर कर्तुलकार दो, गर्भिच्छ्रु सर्श्रित तीन तथा शुक्रार्तव प्रवेशिनी तीन पेशी होती हैं।

महर्षि कापट ने सुश्रुत का अनुगमन किया है। उन्होंने लिखा है कि स्त्रियों में बीस पेशियाँ अधिक होती हैं इनमें दस स्तनों में जिनको यौवन आने पर वृद्धि होती है। दस योनि में होती हैं-आप्यन्तर प्रसृत दो, मुखाश्रित वृत्तकार दो, गर्भमार्ग जिसमें गर्भ स्थित होता है में आश्रित तीन, शुक्रार्तवप्रवेशिनी तीन पेशियाँ। टीकाकार इन्द्र ने शुक्रार्तवप्रवेशिनी पेशियों को गर्भशय्या से प्रतिबद्ध माना है^१।

आचार्य भावमिश्र ने वर्गीकरण में इनकी स्थिति निश्चित रूप से गर्भशय में तीन, गर्भमार्ग या गर्भिच्छ्रु में आश्रित शुक्रार्तव प्रवेशिनी तीन, योनि में चार एवं स्तन में पाँच-पाँच वर्णित की है^२। महर्षि शार्ङ्गधर ने केवल संख्योल्लेख किया है^३।

पुराणों की पूर्ववर्णित लक्षण एवं मुष्क की पेशियों के समकक्ष स्त्रियों में तीन पेशियाँ अन्तर्गत फल को आवृत किये रहती हैं।

Women possess twenty extra *pēṣṭis*, ten in breasts i.e. five in each one which develop in adolescence; four in *aparyapatha* i.e. two spreading inside and two situated in orifice in circular fashion, *garbhachidra* or *grahamāṅga* has three and three are responsible for entry of *śukra* (semen) and *ārtava* (ovum).

Analogous to the *pēṣṭis* of *lakṣana* and *muṣka* of males, the females have three more, covering internally situated *phala*.

विमर्श (Comments)

संहिताओं में पेयि शब्द मांसपेशी, कला एवं स्नायु आदि अनेक रचनाओं के लिए स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हुआ है; अतः पेयि शब्द से किसी विशिष्ट रचना का निर्देश कठिन हो जाता है। स्त्री-शरीर-वर्णित सभी विशिष्ट पेशियों का आधुनिक वर्णित रचनाओं से निश्चित सामंजस्य करना कठिन है, फिर भी निम्नाङ्कित वर्णन ग्रहण किया जा सकता है।

(अ) स्तन में स्थित दस पेशियाँ

स्त्री स्तन में पुरुष से अधिक कोई विशिष्ट पेशी नहीं होती। स्त्री का प्रत्येक स्तन सौत्रिक तंतु से निर्मित आच्छदों द्वारा विभिन्न भागों में विभाजित होता है। युवावस्था का स्तन संयोजकतन्तु, वसा, दुग्ध-ग्रन्थियाँ एवं दुग्धहरणी नलिकाओं से बना होता है। इन नलिकाओं एवं चूचुक में मांसतन्तु अवश्य होते हैं पर उनका इन पाँच पेशियों से सामंजस्य कठिन प्रतीत होता है।

(आ) जननांग की दस पेशियाँ

स्त्री-जननांग-स्थित पेशियों को आचार्यों ने चार वर्गों में विभक्त किया है। इन पेशियों का स्पष्टीकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है जो तालिका संख्या एक से स्पष्ट है।

१. तिष्ठश्च गर्भशये शुक्रार्तवप्रवेशिन्यो गर्भशय्यायां प्रतिबद्धाः ॥ (अ० सं० शा० ५/९१ इन्द्र टीका)
२. स्त्रीणामपि भवन्त्येताः किंचु विशतिरवरा। गर्भशये गर्भमार्गो योनौ च स्तनयोरपि ॥
- स्त्रीणामधिका विशतिरवरा-गर्भशये तिष्ठः ३। गर्भिच्छ्रुसंश्रिताः शुक्रार्तवप्रवेशिन्यस्तिष्ठः ३। योनावप्यन्तरतो मुखाश्रिते प्रसूते द्वे २। योनावेव बहिर्निर्गते सेतोःगर्भशयस्थिते कर्तुले योनिर्गतेति यावत् दे २। स्तनयोः पञ्च ५, पञ्च ५। यौवने तासां वृद्धिर्भवति ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/१४६)
३. स्त्रीणां च विशत्यधिकाः। (शा० सं० पूर्व० ५/४)

तालिका १			
पेशी-वर्ग	आचार्य धाणेकर का मत ^१	पं० गंगाधर जोशी का मत ^२	
१-मुखाश्रित वृत्ताकार स्थित दो पेशियाँ	स्मिन्कट्ट वंजाङ्गी	लेब्वे मेजॉरा तथा माइजॉरा	
२-अध्यान्तर आश्रित या प्रसृत दो पेशियाँ	दू मस्कुल लेअं ऑव वैजिजल कैल (इन सैक्युल तथा आउट लॉन्जिट्युडिनल)	दोनो ब्राड लिंगोमेंट	
३-गर्भमार्ग या गर्भीछिद्र-स्थित तीन पेशियाँ	थ्री मस्कुल लेअं ऑव युटर्स	काडिनल तथा यूटरोसैकुरल लिंगोमेंट एवं प्यूबॉस-व्हाइकल पेशियाँ	
४-शुक्रार्तव प्रवेशिनी तीन पेशियाँ	मस्कुल लेअं ऑव फेलोपिअन ट्यूब	इन्डोसैल्लिकस २ इन्डोमेट्रिअम १	

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों ही विद्वत्-जनों में किसी एक के मत को अक्षरशः स्वीकार करने में निम्न बाधाएँ उपस्थित होती हैं:

- (अ) योनिनलिका में मांसतनु आड़े-तिरछे कुण्डलिकाकार फैले होते हैं, प्राचीन पुस्तकों का बहिर्लम्बाकार तनु एवं अंतःवर्तुलाकार तनु वर्णन युक्तिसंगत नहीं है।
 - (आ) यद्यपि गर्भाशय में तीन पेशी-स्तर होते हैं पर उन्हें पृथक् करना सामान्यतया सम्भव नहीं होता, अतः इन पेशी-स्तरों को पृथक् पेशी की संज्ञा देना समुचित प्रतीत नहीं होता।
 - (इ) डिम्बप्रणाली में तीन पेशी-स्तर न हो कर दो ही होते हैं, जब कि शुक्रार्तव प्रवेशिनी पेशियाँ तीन मानी गई हैं।
 - (ई) पेशी शब्द को यदि बन्धन एवं आच्छद आदि के समकक्ष मान लिया जाय तो भी स्लेष्मल कलाओं को पेशी के अन्तर्गत समावेश करने में कठिनाई होगी क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर होते हैं, यद्यपि गर्भाशयिक अंतःकला को सुगमता से पृथक् किया जा सकता है, परन्तु डिम्बप्रणाली-स्थित स्लेष्मल कला का पृथकीकरण उतना सुगम नहीं है।
 - (उ) वर्ग तीन में वर्णित काडिनल तथा यूटरोसैकुरल लिंगोमेंट्स युग्म बन्धन होते हैं अतः संख्या तीन के स्थान में पाँच हो जाती है, यदि युग्म बन्धनों को दो न मानकर एक माना जाय तो वर्ग दो में वर्णित दो पेशियों के समकक्ष युग्म बन्धन ब्रांड लिंगोमेंट को दो पेशी मानना युक्तिसंगत नहीं होगा।
- उपर्युक्त आंशकालों को दृष्टि में रखते हुए इन पेशियों के बारे में एक अन्य वर्णन निम्न प्रकार से दे सकते हैं।

(१) योनि के बहिर्मुख में स्थित वर्तुलाकार पेशियाँ

यद्यपि योनिनलिका की आकृति का निर्माण अधिकांशतः लिवर्टेनी पेशियों द्वारा सम्पन्न होता है, परन्तु इसके बहिर्मुख या इन्ट्रैडटर्स की आकृति निर्धारण में बल्बोवैकनोसस पेशी-तनु भाग लेते हैं, जो योनिद्वारा में संकोचक प्रभाव डालते हैं, अतः इन्हें रिफ्रैक्टवैजनी शब्द से भी सम्बोधित किया गया है। शयच्छेद के समय त्वचा एवं वसा के स्तर को पृथक् करने के उपरान्त यह वर्तुलाकार आकृति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यह पेशी दोनों लिंगों में समान रूप से उपस्थित रहती है पर यह तर्क निराधार है क्योंकि योनिबहिर्मुख निर्माण करने वाले वर्तुलाकार पेशीतनुओं

१. सु० सं० शा० ५५१ एवं ५३ आचार्य धाणेकर टीका। (पृष्ठ सं० १६३)

२. आयुर्वेदिक कन्सेप्ट्स इन गायनिकोलॉजी। (डॉ० नि० ग० जोशी)

का पुरुषों में अभाव होता है (चित्र ४/१)।

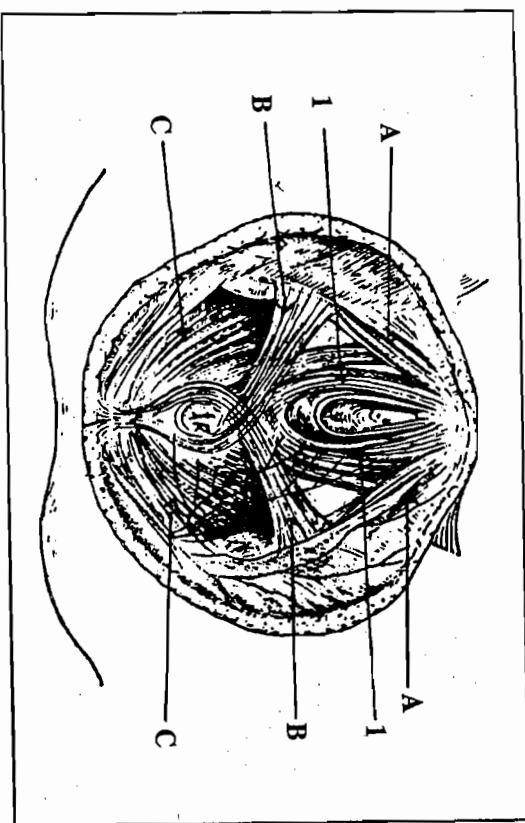


Fig. (4/1) : Showing *pests* of *yonibahirumukha* (muscles of introitus)

- U. Urethra, V-Vagina
- A. Ischio-cavernosus muscles
- B. Transversus perinei muscles
- C. Levatorani muscles
1. Bulbocavernosus muscles-varūākāra (outer circular) two *pests* (muscles) of *yonibahirumukha* (introitus)

(२) अध्यान्तर प्रसृत दो पेशियाँ

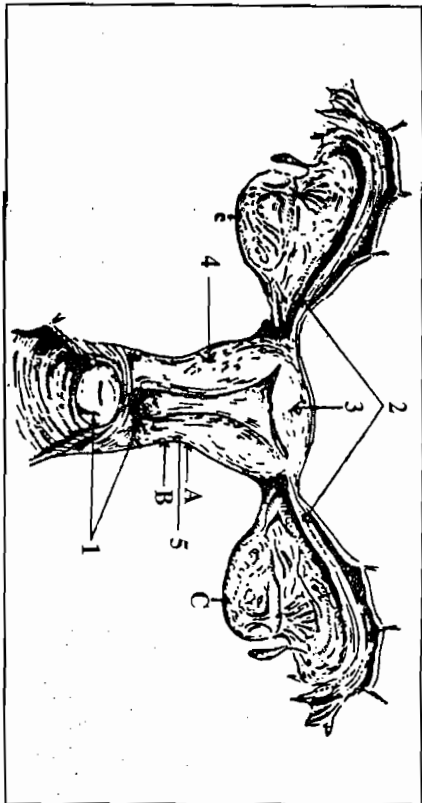
योनि की पूर्व एवं पश्चिम भित्तियाँ सामान्यतः आपस में मिली सी रह कर नलिका को 'यच्' अक्षर का आकार प्रदान करती हैं। शरीर-रचना-दृष्ट्या ये दोनों ही भित्तियाँ प्रमुख विशेषताएँ रखती हैं क्योंकि पूर्ण भित्ति योनि को मूत्रनलिका एवं मूत्राशय तथा पश्चिम भित्ति मलाशय से पृथक् करती है, अतः इन दोनों भित्तियों को आभ्यन्तर प्रसृत दो पेशियाँ माना जा सकता है (पृष्ठ ९ का चित्र १)।

योनिनलिका के मांसपेशी-स्तर के बाहर की ओर संयोजक तनुओं से निर्मित एक घना आच्छद होता है जो पूर्व में प्यूबॉस-व्हाइकल एवं पश्चिम में रेक्टोवैजिनल फेसों का निर्माण करता है; यदि इस आच्छद को भी पेशी के अन्तर्गत मान लिया जाय तो आभ्यन्तर प्रसृत दो पेशियों में मांसपेशी स्तर एवं संयोजकतनु निर्मित उपर्युक्त फेसों को ग्रहण कर सकते हैं।

(३) गर्भीछिद्र-संस्थित तीन पेशियाँ

महर्षि सुश्रुत ने वर्णन के समय गर्भीछिद्र शब्द प्रयोग किया है जिससे गर्भाशयग्रीवा ग्रहण किया जा सकता है एवं युग्म बन्धों को एक मानकर गर्भाशयग्रीवा से सम्बन्धित प्यूबॉस-व्हाइकल, काडिनल तथा यूटरोसैकुरल बन्धनों को तीन पेशियाँ माना जा सकता है। महर्षि वाग्भट ने गर्भमार्ग-स्थित तीन पेशियाँ बताई हैं। गर्भमार्ग एवं अपत्यपथ दोनों का शब्दार्थ एक ही होता है। अपत्यपथ या योनिनलिका का वर्णन पूर्ववर्णित पेशियों में आ जाता है, अतः पुनस्तुति दोष होता है, सम्भवतः इसी विचार से 'गर्भमार्गाश्रयाः यस्यां गर्भीसिद्धिः' स्पष्टीकरण दिया है, जो निश्चय ही गर्भाशय का वर्णन है। गर्भाशय स्थित

तीन पेशियों से गर्भाशय के फ़ंनटस, कॉःक्स तथा इस्पर्मस को लिया जा सकता है (चित्र ४/२, ३)। इन तीनों अंगों को विभिन्न पेशी मानने से सम्बन्धित तर्क निम्नलिखित हैं।



Fig(4/2) : Showing *pēśīs* of females.

1. Cervix of uterus—*śukrapraveśiṇī pēśī* (muscle responsible for entry of sperms).
 2. Both fallopian tubes—*āranvapraveśiṇī two pēśīs* (two muscles responsible for entry of ovum).
 3. Fundus of uterus
 4. Corpus of uterus
 5. Isthmus of uterus
- A. Anatomical os. B. Histological os. C. Ovaries.

(अ) गर्भाशय-बुध (फ़नटस)

१-डिम्बप्रणाली के प्रवेश से ऊपर का भाग सामान्य रूप से एवं विशेषकर अनुलम्ब छेदन में शेष गर्भाशय से पृथक् सा दिखाई देता है।

२-कतिपय जन्मजात-विकार जैसे यूटर्स आक्युइटस एवं यूटर्स बाइकोनिस आदि गर्भाशय के केवल इसी भाग को प्रभावित करते हैं।

३-प्रसव के समय यह भाग सर्वाधिक क्रियाशील रहता है।

(आ) गर्भाशय-अधोभाग (इस्पर्मस)

(१) यह गर्भाशय का सबसे निचला गर्भाशयग्रीवा से सम्बन्ध स्थापित करने वाला ०.९ से ०.५ सेमी० भाग है। इस भाग में अपेक्षाकृत मांसतनु विशेषतः तन्वाकृति मांसतनु बहुत कम होते हैं, एवं यहाँ की श्लेष्मल कला रचना एवं क्रिया दृष्ट्या गर्भाशय-शरीर एवं गर्भाशय-ग्रीवा-स्थित श्लेष्मल कला के मध्य की होती है। गर्भाशय-शरीर एवं इस्पर्मस के मिलने वाले संकुचित भाग को एंटीमिसेल ऑस कहा जाता है।

(२) यह भाग गर्भाशय के प्रारम्भिक दिनों में अति मृदु हो हेमर लक्षण उत्पन्न करता है।

(३) गर्भ की वृद्धि के साथ यह अंग सामान्य गर्भाशय में एकाकार सा हो मांसतनुओं की अपेक्षाकृत कमी के कारण पतला होकर लोअर सेगमेंट का निर्माण करता है।

(४) अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह भाग प्रसव के समय सक्रिय रूप से संकुचित नहीं होता।

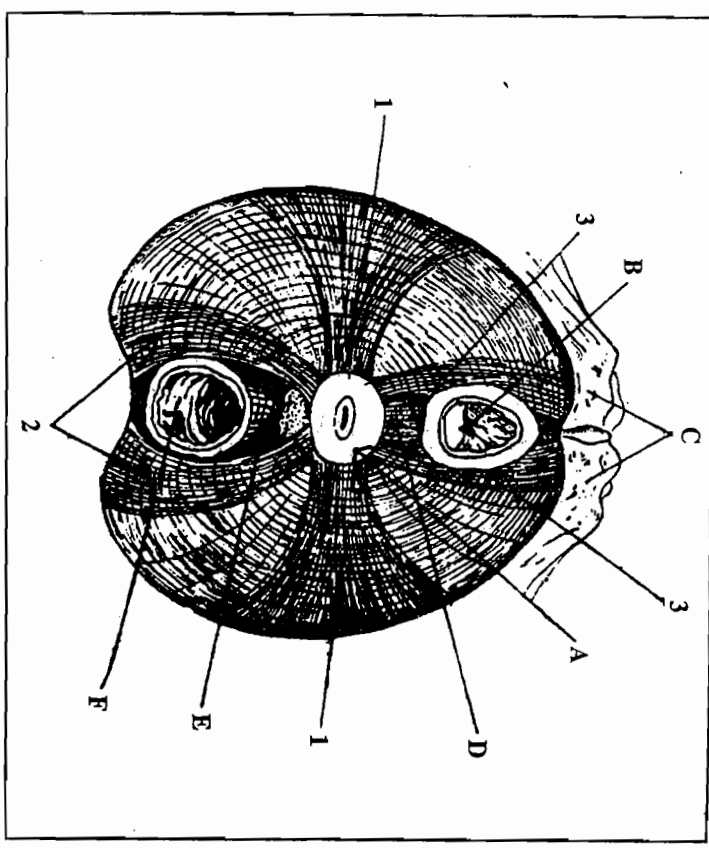


Fig. (4/3) : Muscles of *garbhachidra* (another explanation)

- A. Cervix. B-Internal urethral orifice. C-Pubis. D-Ant. vaginal wall. E-Cul-DE-Sac., F. Rectum
 1. Transverse cervical or cardinal ligaments
 2. Uterosacral ligaments
 3. Pubocervical ligaments
- Three muscles situated in *garbhachidra*.

(इ) गर्भाशय-शरीर (वाड़ी)

गर्भाशय के दो भाग गर्भाशय-बुध एवं इस्पर्मस पृथक् हो जाने के बाद तीसरा गर्भाशय-शरीर स्वयमेव पृथक् हो जाता है।

(४) शुक्रार्तव प्रवेशिनी तीन पेशियाँ

शुक्र (स्रंम) तथा आर्तव (ओवम) के प्रवेश में सहायक पेशियों को दो भागों में विभक्त करना पड़ेगा अर्थात् शुक्रप्रवेशिनी एवं आर्तवप्रवेशिनी। प्रथम वर्ग में एक पेशी-स्वरूप गर्भाशय-ग्रीवा एवं द्वितीय वर्ग में दो पेशियों के रूप में डिम्बप्रणालियों को ग्रहण कर सकते हैं (चित्र ४/२)। इस तर्क के निम्नलिखित प्रमाण हैं। टीकाकार इन्दु ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये तीन पेशियाँ गर्भाशय से प्रतिबद्ध रहती हैं।

१. तिलक गर्भाशये शुक्रार्तवप्रवेशिन्यो गर्भाशयाया प्रतिबद्धाः। (अ० सं० शा० ५/१९ इन्दु टीका)

(अ) शुक्रप्रवेशिनी एक पेसी या गर्भाशय-ग्रीवा

(१) सामान्यतया योनिमिलिका की प्रतिक्रिया अस्थायी होती है जिसमें शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते। संभोग के समय गर्भाशय-ग्रीवा ग्रन्थिस्त्राव, गर्भाशयात्मकता-स्त्राव एवं बाधालिन आदि ग्रन्थियों के स्त्राव मिलकर इसे क्षारीयता में परिवर्तित कर शुक्राणु-जीवन-योग्य बनाते हैं। गर्भाशय-ग्रीवा की कुछ वैकृतिक अवस्थाएं यथा जीर्णशेष या अवरोध आदि शुक्राणु-प्रवेश-बाधक हो सकते हैं।

(२) सामान्य अवस्था में गर्भाशय-ग्रीवा शुक्र-स्त्राव में परती-भाँति आत्मावित हो शुक्राणु-प्रवेश-सहायक होती है। गर्भाशय की तीव्र अग्रिम या पश्चिम प्रेश की अवस्था में गर्भाशय-ग्रीवा अत्यधिक उर्द्धा या अपवर्त हो शुक्राणु-प्रवेश-बाधक होती है।

(३) गर्भाशय-ग्रीवा-स्थित श्लेष्मा सामान्यतया ऋतुकाल में (रजःकाल के बाद लगभग १२ या १६ दिन या ईस्ट्रोजेन-प्राधान्य की अवस्था में) शुक्राणु-प्रवेश-योग्य होता है, यही, बाद में (प्रोजेस्टेरोन की प्रधानता में) शुक्राणु-प्रवेश-बाधक होता है।

(आ) अर्धवक्रप्रवेशिनी येशियाँ या दो डिम्बप्राणालियाँ

डिम्बग्रन्थि से स्त्रीबीज निकलकर डिम्बप्राणाली में प्रविष्ट हो डिम्बप्राणाली की गति एवं अन्तःकला (श्लेष्मल कला) स्थित लेमों (सेलिअ) के सहारे आगे बढ़ता है, यदि डिम्बप्राणाली में अवरोध हो जाय तो स्त्रीबीज आगे नहीं आ सकता।

यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शुक्राणु भी अंतर्लोगत्वा डिम्बप्राणाली में ही प्रवेश करते हैं अतः इन्हें शुक्रप्रवेशिनी पेसी क्यों न माना जाय, परन्तु डिम्बप्राणाली के अतिरिक्त कोई अन्य अंग स्त्रीबीज के प्रवेश से सम्बन्धित दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः उपर्युक्त विभागा करना पड़ता है।

Word *pest* in *āyurveda* has been used to denote *facia*, *muscle*, *tendon* and *ligaments* etc. in different contexts.

Breasts or even chest of female do not contain any extra muscle than male, thus, it is difficult to explain ten *pests* of breasts.

The muscles of female reproductive system have been classified under four sub-groups. These muscles have been explained in following way by previous writers-

Groups of <i>Pest</i>	OPINION OF	
	Dr. Ghāṇakara	Pt. Gaṅgādhara Josī & Dr. N. G. Josī.
1. Two outer circular	Sphincter vaginae	Labia majora and minora
2. Two spreading inside	Two muscular layers of vaginal canal (inner circular and outer longitudinal)	Both broad ligaments
3. Three situated in <i>garbhā-mārga</i> or <i>garbhachidra</i>	Three muscular layers of uterus	Cardinal ligaments, uterosacral ligaments and pubocervical fascia
4. Three responsible for entry of <i>śukra</i> and <i>ārtava</i>	Muscular layers of fallopian tubes	Endosalpinx-2 Endometrium-1

The above explanation of either of the authors can not be accepted in toto due to following reasons-

(a) The fibres of muscle-coat of vaginal canal are nearly all arranged in criss-cross fashion, rather than in the outer longitudinal and inner circular pattern. (b) uterine muscle fibres in most part run obliquely in criss-cross fashion, though most superficial and deepost fibres are, however, arranged longitudinally, thus layers become three, but it is not easy to separate these layers; (c) fallopian tubes contain only two muscular layers, not three; (d) if broad ligaments are to be considered as two separate *pests* then uterosacral and cardinal ligaments being twin ligaments should also be considered as four, which will increase the number to five of this sub-group; (e) though endometrium can be seen with naked eye yet mucous membrane of fallopian tubes is not easily discernible, as it is microscopic structure, thus, to consider this as a separate *pest* is also not proper.

Considering these facts, other explanations may be given in following way-

i) Outer circular (in orifice of vagina)

Muscle fibres of bulbocavernosus muscles encircling introitus or sphincter vaginae may be considered under this heading. Though this muscle is present in both sexes, yet, these particular groups of fibres are absent in male (page 23; fig 4/1).

ii) Two spreaded inside (the vaginal canal)

Either anterior and posterior vaginal wall or muscular layer of vagina and connective tissue layer making pubocervical and rectovaginal fascia can be taken (page 9; fig. 1).

iii) Three situated in *garbhachidra*

Considering twin ligaments as one structure and with *garbhachidra* the cervix uteri, the pubocervical, cardinal and uterosacral ligaments may be kept in this group. If this is to be taken as uterus, then fundus, corpus and isthmus may be considered as three *pests* (page 24, 25; fig. 4/2 & 3.) due to following points--

In transverse section the portion of uterus above the insertion of fallopian tubes i.e. fundus looks separate from remaining body. Fundus and isthmus are anatomically and physiologically distinct as fundus has thickest muscular layer, uterus arcuatus etc. congenital abnormalities involve only fundus, it plays dominant role in expulsion of fetus. Isthmus, the lowest part of uterus, joins it with cervix, has relatively lowest amount of muscle fibres specially longitudinal, mucous lining is inbetween endometrium of uterus and endocervix, it gets softend in early months of pregnancy giving rise to Hegar's sign, it forms lower uterine segment and does not take active part in expulsion of fetus. Once fundus and isthmus are isolated remaining portion i. e. corpus automatically becomes third one.

iv) Three responsible for entry of sperms and ovum

Cervix uteri may be taken as responsible for entry of sperms, as it is accepted that certain conditions of cervix or its mucus can hinder entry of sperms in uterus. Ovum enters

through fallopian tubes, hence these two may be taken as responsible for entry of ovum (page 24, fig. 4/2).

(इ) लक्षण एवं मुष्क के समकक्ष पेशियाँ (Pests analogous to lakṣaṇa and muṣka)

सुश्रुत टीकाकार डल्हन ने लक्षण शब्द से पुरुष का शिश्न ग्रहण किया है; मुष्क वृषण (स्कर्टम) को निर्दिष्ट करता है; इनकी पेशियों के समकक्ष स्त्री-शरीर-स्थित 'फल' की पेशियों को एवं 'फल' से गर्भाशय मानकर गर्भाशय का ही वर्णन स्वीकार किया है। गर्भाशय का वर्णन इसके पूर्व आ चुका है। सम्भवतः इसी विचार से प्रेरित होकर इन्होंने भोज-वाक्य उद्धृत करते हुए स्त्रियों में इन पेशियों की अनुपस्थिति बताई है। भावप्रकाश में भी यही विचार मिलते हैं।

श्री गणानाथ सेन तथा आचार्य बाणोकर ने लक्षण से स्त्री की भगशिश्निका (क्लिटेरिस) एवं मुष्क या वृषण के समकक्ष डिम्बग्रन्थि (ओवैरिज) की पेशियों का ग्रहण किया है।

विषय पर आगे विचार करने से पूर्व 'फल' शब्द पर विचार आवश्यक है। यह शब्द यहाँ पर एकवचन में प्रयुक्त है। संहिताओं में उद्धृत एवं / अथवा अपवृत्त फल-योनि में क्षारकर्म निर्भिद्ध बताया गया है। यहाँ पर 'फल' शब्द से आचार्य डल्हन ने गर्भाशय, हारणचन्द्र ने आंत एवं अरुणदत्त ने रज का अर्थ ग्रहण किया है। आधुनिक लेखकों ने 'फल' को बीज-साधन होने से डिम्बग्रन्थि का द्योतक माना है।

इस स्थान पर 'फल' शब्द का प्रयोग प्रंश के सम्बन्ध में किया गया है। डिम्बग्रन्थि या आंत का अधोप्रंश तो किसी सीमा तक दृष्टिगत होता है, पर इनके ऊर्ध्व-प्रंश की स्थिति होती ही नहीं, यदि किसी प्रकार ऊर्ध्व-प्रंश मान भी लिया जाय, तो दृष्टिगत न होने से क्षार-कर्म का प्रश्न नहीं उठता; रज का प्रंश नहीं होता, अतः यहाँ पर 'फल' शब्द से गर्भाशय अर्थ लेना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, एवं 'फल-योनि' को 'फलस्य (प्रसवस्य) योनि' मान लेने से 'फल' (प्रसव) का साधनभूत 'गर्भाशय' अर्थ समझा जा सकता है।

१. केचित्तन्त्रकाराः स्त्रीणां मेहुमुष्काभावात्तदाश्रितान् पेशीनामन्यत्रावस्थानं पठन्ति । तन्मतमाह-भक्ती चात्रेत्यादि। लक्षणमुष्कजा इति तस्यैव ज्ञायते पुमाननेनेति लक्षणं लिङ्गं शिश्नमिति यावत् । फलं गर्भाशयः । ता इति पेश्यः । गयी तु अमुं तन्त्रान्तरीय श्लोकं न पठति । किन्तु एवमेतां पञ्च पेशीनां इत्यत्र पुंसामिति पदं पठित्वा पुंसानेव पञ्चपेशीनां, स्त्रीणामु तिसृभिर्लूकानि पञ्चशतानेति व्याख्याति । अत्राद्यं च भोजवाक्यं दृष्टान्ती करोति । तक्षव भोजवाक्यं- 'पञ्चपेशीशतान्येव स्त्रीचर्तं विद्धि भूषिप । अतश्च तिस्रो हीयन्ते स्त्रीणां शेषमसि मुक्तयोः' - इति ॥ (सु० सं० शां० ५/४१ डल्हन टीका)

२. अस्यायमर्थः पुसां मेहनमुक्तयोश्च यातिस्तस्य मांसशयः पूर्वमुक्तास्ताः स्त्रीणां मेहनमुष्काभावात् फलं गर्भाशयमावृत्तं विधन्ति । (इन्होंने भी गायदास एवं भोज-वाक्य उद्धृत किया है) । (भा० प्र० पूर्व० ३/१४०)

३. (अ) अथ तैत्तिरीयश्रौतान्तराः - तद्यथा-दुर्वृत क्लीबाणवृत्तेद्वृतफल-योनिः । (सु० सं० सू० ११/२८)

(आ) न तूभयोऽपि योज्यो.....उद्धृतफल-योनिः । (अ० सं० सू० ३१/५)

(इ) न तूभयोऽपि योज्य ।प्रोद्धृतफल-योनिः ॥ (अ० ह० सू० ३०/४ एवं ६) ॥

४. (अ) उद्धृताणवृत्तफल-योनिः । इति उद्धृताणवृत्तशब्दौ फल-योनिभ्यां सह प्रत्येकं सम्बध्यते । फलमण्डप, योनिर्गर्भाशयः उद्धृतफलः स्थानपूर्वगतण्डः अपवृत्तफलः स्थानात् सस्ताण्डः, उद्धृतयोनिः स्थानादूर्ध्वगतयोनिः, अपवृत्तयोनिः स्थानात् सस्तायोनिः अन्ये तु फल-योनिशब्देन समुदितेन गर्भाशयमावृत्तते तन्नामर्थः- उद्धृतफल-योनिः स्थानादूर्ध्वगतगर्भाशयः, अपवृत्तफल-योनिः स्थानात् सस्तागर्भाशयेत्यर्थः ; अग्रे तु फलशब्दं रजसि वर्तयन्ति, कुतः ? गर्भस्य फलसाधनत्वात् । तेन यस्याः योनेः सकाशात् फलं रज उद्धृतपूर्वगतमपि, अपवृत्तं अपोनाम, सा उद्धृताणवृत्तफल-योनिः ॥ (केचित्तु फलशब्देनान् ग्रहान्तरुपचारादङ्गायां घोष इतिवत्, इति हारणचन्द्रः- पुस्तक की पाद टीका में)

(सु० सं० सू० ११/२८ डल्हन टीका)

(आ) प्रकर्षणोद्धृत फल-रजोत्सं, यस्या योनेः सा प्रोद्धृतफल-योनिः । रज एव फलं गर्भाशयफलसाधनोपायत्वात् ॥

(अ० ह० सू० ३०/६ असण० टीका)

जैसा मर्मन्तरांत वर्णित है कि महर्षि सुश्रुत ने अश्वरी की विकिरता करते समय विचारणीय आठ मर्मों में 'स्रोतसीफल-योः' शब्द का प्रयोग किया है, इसे स्त्री-शरीर-स्थित डिम्बग्रन्थि माना जा सकता है। गर्भाशय को मर्म नहीं मान सकते क्योंकि इसकी न तो मर्म-संख्या में ही कहीं गणना की गयी है और न ही इस अंग में आघात या सम्पूर्ण छेदन होने से मर्म-वैध से उत्पन्न होने वाले प्रभाव (सद्यःप्राणह, कालान्तरप्राणह, विशल्यध, रुजाकार एवं वैकल्पिकर) ही देखे जाते हैं, अतः ऐसा माना जा सकता है कि एकवचन में प्रयुक्त 'फल' शब्द गर्भाशय का एवं द्विवचन में प्रयुक्त डिम्बग्रन्थियों का द्योतक है।

जैसा पूर्व वर्णित है, लक्षण एवं मुष्क शिश्न एवं वृषण माने गये हैं। वृषणों में पेशी तन्तु नाण्य होते हैं परन्तु अण्डकोष पेशी-निर्मित होता है, अतः यहाँ मुष्क से अण्डकोष अर्थ लेना युक्तिसंगत होगा एवं शिश्न के समकक्ष स्त्री की भगशिश्निका तथा अण्डकोष के समकक्ष बृहत्भगोष्ठ मान सकते हैं। बृहत् भगोष्ठों में पुरुष-अण्डकोष-स्थित डाःटॉस पेशी सदृश मांसतन्तु रहते हैं (चित्र ४/४)। इस वर्णन को मान लेने पर 'फलमन्तरांत' हि ताः 'जिसके अन्तरांत या नीचे फल या गर्भाशय स्थित है' ऐसा अर्थ करने से विषय स्पष्ट हो जाता है।

उपर्युक्त सभी पेशियों का वर्णन संहिता रूप में तालिका २ में किया गया है।

संहिता-वर्णन	तालिका २
१. रसनागत दस पेशियाँ	समकक्ष पेशियाँ
२. जननांग की पेशियाँ	स्तन के भिन्न विभाग
(अ) बहिर्द्वार-स्थित चतुर्ललाकार दो पेशियाँ	सिफ्फ-क्लैट वेंजइनी
(आ) अपत्यपथ में आध्यान्तर प्रसृत दो पेशियाँ	योनि की पूर्व एवं पश्चिम भित्ति या योनि के मांसल एवं संयोजक-तन्तु-निर्मित आच्छद
(इ) गर्भाछिद्र सम्बन्धित तीन पेशियाँ	गर्भाशय-बुध, शरीर एवं निम्न भाग या प्यूबॉसर्व इकरल, यूटरोसैक्रेल तथा काडिनल बन्धन
(ई) शुक्रार्तवप्रवेशिनी तीन पेशियाँ	गर्भाशय-ग्रोवा
i) शुक्रप्रवेशिनी-एक	दोनों डिम्बग्रन्थालित्याँ
ii) आर्तवप्रवेशिनी-दो	
३. पुरुष के समकक्ष पेशियाँ	भगशिश्निका
(अ) लक्षण (शिश्न) की पेशी-एक	दोनों बृहत् भगोष्ठ
(आ) मुष्क (अण्डकोष) की पेशीयाँ-दो	

Dalhana explains *lakṣaṇa* as penis and *muṣka* as *vr̥ṣana* and has opined that muscles of uterus may be considered analogous to these muscles, however, quoting Bhoja he writes that as uterus is already described earlier, thus, these may be considered absent in woman.

Before proceeding further let us examine the word '*phala*' which has appeared here.

The word *phala* has appeared in reference to *kṣāra karma* where in its application in

१. सु० सं० चि० ७/३६ एवं ३८ (पु० १६)

“*udvṛtta* or *apavṛtta-phala-yoni*” is contraindicated. The question of application of *kṣāra* in ovaries in their displacements does not arise, because these are intraperitoneal structures. Again ‘*phala*’ in dual number has appeared in the list of vital parts. Uterus can not be considered a vital part because injury to this does not produce immediate death (*sadyaḥ prāṇahara marmā*), delayed death (*kāṇtāra prāṇahara marmā*), death after removal of foreign body from this (*viśalyaghna marmā*), severe pain (*ruiākara marmā*; endometrial biopsy is performed without much pain to woman) or permanent disability (*vaikālyakara marmā*); while injury to ovaries can produce at least permanent disability. With this description it may be concluded that word ‘*phala*’ in dual number indicates ovaries and in singular number the uterus.

Clitoris of female is similar to *lakṣṇa* or penis of male which has got sufficient erectile muscle fibres, testes and their counterpart ovaries do not contain muscles, the fibers

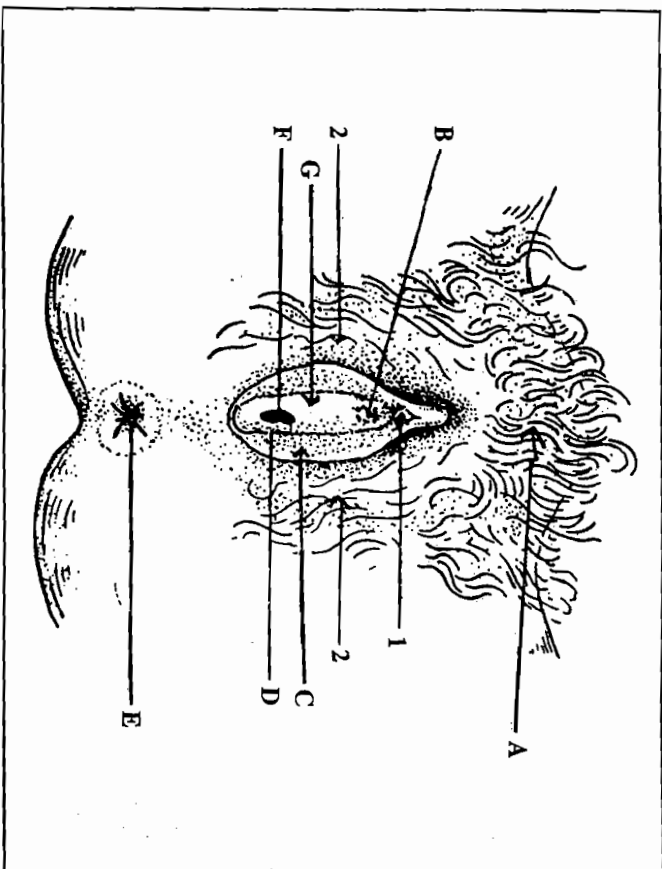


Fig. (4/4) : Showing *peśis* (muscles) of female analogous to *lakṣṇa* (penis) and *muṣka* (scrotum) of male.

1. Clitoris—muscle analogous to penis
2. Labia majora—muscles analogous to scrotum
- A. Mons Pubis
- B. External urethral meatus
- C. Labia minora
- D. Hymen
- E. Anal orifice
- F. Introitus of vagina
- G. Vestibule

present are microscopic structure, thus with *muṣka* scrotum should be considered and analogous to the scrotum female possess labia majora, and behind these uterus is, situated (fig. 4/4).

Preceding interpretation of *peśis* is summarized in tabular form:

Description in classics	Muscles
A) <i>Peśis</i> of breasts B) <i>peśis</i> of reproductive system 1) Outer circular—1 2) Spreading inside—2	Different parts of breasts Sphincter vaginae Anterior and posterior vaginal wall or muscular layer and pubocervical along- with rectovaginal fascia A) Uterosacral, cardinal and pubocervical ligaments B) Fundus, corpus and isthmus of uterus.
3) Situated in <i>garbhachidra</i> —3	
4) Responsible for entry of sperm and ovum-3 a) for sperm—1 b) for ovum—2 5) Analogous to penis—1 to scrotum—2	cervix uteri both fallopian tubes clitoris labia majora.



अध्याय २ CHAPTER II

ऋतुचक्र एवं उसका शारीर-क्रिया विवेचन (PHYSIOLOGY OF MENSTRUAL CYCLE)

शारीरिक वृद्धि की अवस्थाएं (Stages of life according to development)

यद्यपि आधुनिक संहिताओं में राजःश्रावादि पर आधारित अवस्थाओं का वर्णन नहीं मिलता, पर यन्-तन्त्र वर्णित विषय का संकलन करने से एक सामान्य रूपरेखा प्रकट होती है। अतः विशिष्ट विषय में प्रवेश के पूर्व इन अवस्थाओं का सामान्य ज्ञान वर्णित है। सम्बन्धित संदर्भ निम्नोक्त हैं-

वयो यथास्थूलभेदेन त्रिविधः-बालं, मध्यं, जीर्णमिति । (च० सं० वि० ८/१२२)
वयसु त्रिविधं, बाल्यं मध्यं वृद्धमिति । (सु० सं० सू० ३५/२९)
वयस्त्रिविधं बालं मध्यं वृद्धं च । (अ० सं० शा० ८/२४)
गर्भं बालकुमाराख्यमित्येतत्त्रिविधं वयः ।
यौवनं मध्यमं वृद्धमेतच्छ त्रिविधं पुनः ॥ (का० सं० वि० ३/७२)

सभी आचार्यों ने सम्पूर्ण आयु को स्थूल रूप से बाल्यावस्था, मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया है; महर्षि काश्यप ने लिखा है कि गर्भ, बाल एवं कुमार तीन प्रकार तथा पुनः यौवन, मध्य एवं वृद्ध तीन प्रकार की आयु होती है, अर्थात् इन्होंने बाल्यावस्था के तीन यथा गर्भ, बाल एवं कुमार तथा शेष आयु के तीन यथा यौवन, मध्य एवं वृद्ध, विभागा किए हैं। महर्षि हरित ने मध्यावस्था को दो यथा यौवन एवं मध्यम में विभाजन करते हुए चार अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन सभी अवस्थाओं में शरीर के अन्तर्गत विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। स्त्री-शरीर की विशिष्ट प्रक्रियाओं में बाला एवं मध्यावस्था ही भाग लेती हैं।

There is no clear description of various epochs of woman's life, however, scattered references present a general picture. Before discussing specific epochs of woman, revision of general classification of age is essential.

The life span is divided into three stages—*bālāwashā* (childhood), *madhyamāwashā* (adult age) and *vr̥dhāwashā* (old age). Kāśyapa has classified age into three groups, *garbha*, *bāla* and *kumara* and again into three groups i. e. *yauvana*, *madhyama* and *vr̥ddha*. In other words after classifying the age of childhood separately into three, the remaining span of life is divided into *yauvana* etc. three stages. Harita has classified age into four subdividing middle age into two i. e. *yauvana* and middle.

१. बालं युवानं वृद्धं च मध्यमं च तथैव च । चतुर्विधं वयः सम्यक् तत्समासेन वक्ष्यते ॥ (हा० सं० प्र० स्था० ५/२)

(अ) बालावस्था (Childhood)

तत्र बालमपरिवक्त्रधातुमजातव्यञ्जनं मुकुमारमकलेशसहस्रमसंपूर्णबलं श्लेष्मशानुप्रायमाशोडशवर्षम् ।

(च० सं० वि० ८/१२२)

तत्रोन्मोडशवर्षीया बालाः । (सु० सं० सू० ३५/२९)
बाले विवर्द्धते श्लेष्मा (सु० सं० सू० ३५/३१, भा० प्र० पूर्व० ४/४९)
तत्राशोडशाष्टाधत्वात् । तस्मिन् देहप्रमाणवृद्धिः श्लेष्मोद्रेकश्च ।
तेन बालस्य स्नेहमर्दवसौकुमायत्वयोः क्रोधाध्वसौभाग्यानि भवन्ति ॥ (अ० सं० शा० ८/२४)
बालावस्था १६ वर्ष पर्यन्त रहती है, इस अवस्था में शरीर की धातुओं अग्निका होती है, व्यञ्जनादि चिह्न (मूँछ आदि) उत्पन्न नहीं हुए रहते, शरीर कोमल, कलेश सहने में असमर्थ एवं असम्पूर्ण बल से युक्त होता है। श्लेष्मा का प्राधान्य रहता है।

महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा है कि १६ वर्ष तक बालावस्था होती है तथा इसमें कफ का प्राधान्य रहता है। महर्षि वाग्भट ने भी लिखा है कि १६ वर्ष पर्यन्त बालावस्था रहती है, इस अवस्था में देह-प्रमाणों की वृद्धि होती है, श्लेष्मोद्रेक रहता है, जिसके कारण बालक में खेताधिक्य, मुटुला, सुकुमारता, क्रोधात्पला एवं सौभाग्य आदि होते हैं। महर्षि काश्यप ने इस अवस्था को पुनः तीन भागों में विभाजित किया है यथा गर्भ, बाल एवं कुमार; तथा एक वर्ष के बालक को क्षीर एवं बाद में अनाद माना है। विभाजन तो किसी अंश तक सुश्रुत, वाग्भट-द्वय तथा भावप्रकाशकार ने भी माना है, परन्तु इनका विभाजन बालक को आहारदि की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। महर्षि वाग्भट एवं भावमिश्र ने एक स्थान पर बालावस्था की अवधि दस वर्ष तक मानी है। महर्षि चक्र ने इसी बालावस्था के वर्णन में रसादि धातुओं की वृद्धि एवं मन की अस्थिरता के कारण आयु की सीमा तीस वर्ष तक कही है। महर्षि हरित एवं भवमिश्र ने सोलह वर्ष तक की अवस्थाओं को बालावस्था माना है तथा बालावस्था को अल्प शरीर वाला माना है।

This age lasts upto sixteen years. During this span the *dhatūs* are immature, hair on face and axilla are not grown, body is soft and can not withstand troubles, *bala* (strength), is

१. गर्भबालकुमाराख्यमित्येतत्त्रिविधं वयः । वर्षावतः क्षीरयः स्थावरात् पित्रति वा पयः ।
वयस्तद्वालमसमाच्च यावत् शोडशवर्षिकः । अनादः सर्व एव स्यात् कैमारे वयसि स्थितः । (का० सं० वि० ३/७२, ७३, ७४)
२. (अ) तेषां त्रिविधा - क्षीरयाः, क्षीरजाताः, अनादा इति । (सु० सं० सू० ३५/२९)
(आ) तेषां स्तन्याहरोभयवृत्त्या बालं त्रिविधम् । (अ० सं० शा० ८/२४)
(इ) त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्मोभयवर्तनः । (अ० ह० उ० २/१)
(ई) त्रिविधः सोऽपि दुग्धाशी दुग्धाजानी तथाऽभुक् । (भा० प्र० पूर्व० ४/४३)
३. (अ) बाल्ये वृद्धिं प्रभाषेधात्स्वकृष्णकृष्णोद्भूतोद्भूतः । दशके कुमराद्यानि मनः सर्वैर्द्रव्याणि च ॥ (अ० सं० शा० ८/२५)
(आ) बाल्यं वृद्धिरश्वविमेषा त्वदृष्टिः सुक्रविक्रमैः । वृद्धिः कर्मेन्द्रिये चेतो जीवितं दशतो हस्ये ॥ (भा० प्र० पूर्व० ४/५०)
४. त्रिविधमनधातुगुणं पुनः प्रायेणनवस्थितसत्त्वमात्रिशुद्धमनुपदिष्टं ॥ (च० सं० वि० ८/१२२)
५. (अ) आपोऽशाब्दवेद्बालः । (हा० सं० प्र० स्था० ५/४)
(आ) ऊनयोऽश्ववर्षसु नरो बालो निगद्यते । (भा० प्र० पूर्व० ४/४२)
(इ) चतुर्विधं शरीरं स्याद्वाल्यं तथा प्रोक्तं बालयमलशरीरकम् ।
शोडशवर्षिकं यावद्वाल्यं तावत् प्रवर्तते । (हा० सं० प्र० स्था० १/३)

also not fully developed. This span is dominated by *kapha*, so the body is more unctuous, soft, delicate with relatively less anger and in endowed with good fortune.

Kāśyapa has subdivided this span in *garbha* (fetal stage), *bāla* (preschool age), *kumāra* (school age including adolescence). Sūśruta etc. have subdivided it on the basis of dietetic consideration i. e. *kṣīrāyapa* (milk as main diet) upto one year, *kṣīrānāda* (milk and cereals both) from one to two years and *annāda* (cereals) two years onwards, however, Kāśyapa has clubbed *kṣīrānāda* and *annāda* into one. Vāgbhata and Bhāvanīśra at one place bring down the limit just upto ten years, on the other hand, Caraka stretches it upto thirty years considering the attainment of full maturity of *dhātus* and stability of *mana*.

(आ) मध्यमावस्था (Middle age)

मध्यं पुनः समत्वात्तत्त्वतीर्थपरमपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानसर्वधातुगुणं बलस्थिरमवस्थितसत्त्वमविशीर्यमाणधातुगुणं पितृधातुप्रायमबाधिवर्षमुपदिष्टम् ॥ (च० सं० वि० ८/१२२)

षोडशसत्त्वोत्तरे मध्यं त्रयः तस्य विकल्पो-वृद्धिः, यौवनं संपूर्णता परिहाणिति। तत्र आविशतो-वृद्धिः, आविशतो यौवनं, आचत्वारिंशतः सर्वधात्वित्त्रियबलवीर्यसंपूर्णता, अत ऊर्ध्वमीषत्वारिहाणिर्यावत् सचतिरिति। (सु० सं० सू० ३५/२९)

..... मध्यमे पितृमेव तु ॥ (सु० सं० सू० ३५/३१)

आषट्केमध्यम् मध्यमपि त्रिविधं यौवनं संपूर्णत्वमपरिहाणिष्ठ। तीस्मिन् पित्तोद्रेकः तेन दीप्ताग्निता प्रज्ञाधिक्यपरिपाकौ व्यवसायश्च। तत्राविशतो यौवनमाचत्वारिंशतः सर्वधात्वित्त्रियबलवीर्यपरमपराक्रमवचन-विज्ञानप्रश्रयगुणसंपूर्णत्वमतः परमपरिहाणिः ॥ (अ० सं० शां० ८/२४)

अतः परं धातुसत्त्वबलवीर्यपराक्रमैः ॥ ७४ ॥

बध्ममनैश्चतुस्त्रिंशद्वा वर्षाण्युदकैरतः। धात्वादिभिः स्थितेभूतेर्धावदासमतिरतः ॥ ७५ ॥

(का० सं० छि० ३)

मध्यमावस्था में बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन एवं विज्ञान की शक्ति सम्पूर्ण रूप में आ जाती है। सभी धातुयें पूर्ण हो जाती हैं, बल एवं सत्त्व अच्छे रूप में स्थित हो जाते हैं, धातुओं के गुणों में क्षय नहीं हुआ रहता। यह अवस्था ६० वर्ष तक चलती है एवं इसमें पित्त की प्रधानता रहती है।

महर्षि सुश्रुत ने इस अवस्था की मर्यादा ७० वर्ष मानकर इसे पुनः वृद्धि, यौवन, संपूर्णता एवं हानि आदि चार अंगों में विभाजित किया है। बीस वर्ष तक वृद्धि की अवस्था, तीस वर्ष तक यौवनवस्था, चालीस वर्ष तक सर्वधातु, इन्द्रिय, बल एवं वीर्य की सम्पूर्णता एवं इसके पश्चात् ७० वर्ष तक धातुओं आदि के किञ्चित् क्षय की अवस्था होती है। इस अवस्था में पित्त का प्रधान्य रहता है। भवामिश्र ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं।^१

महर्षि वाग्भट ने आयु की सीमा चक्रानुसार ६० वर्ष मानकर इस अवस्था को यौवन, संपूर्णता एवं अपरिहाणि (न क्षय) इस प्रकार तीन भागों में विभाजित किया है। इस अवस्था में पित्त का प्राधान्य होने से दीप्ताग्निता, प्रज्ञा का अधिक्य

१. पच्ये षोडशसत्त्वोर्मध्यमः कथितो बुधैः ॥ ४४ ॥

चतुर्धा मध्यमं वृद्धिर्बुधार्थमभ्यासिचत्त्वम्। मवेदाविशतेवृद्धिर्बुधा त्वाविशतो मतः ॥ ४५ ॥

चत्वारिंशत्समा यावन्निषेष्टीयादिर्युतः। ततः क्रमेण क्षीणः स्वाभाविकवति ससतिः ॥ ४६ ॥

वीर्यादीत्यादिभ्यो रसादिसर्वधात्वित्त्रियबलोत्साह उच्यते। क्षीणः = सर्वधात्वित्त्रियबलोत्साहैर्हीनः ॥

(पा० प्र० पूर्व० ४/४४ से ४६)

एवं परिपाक तथा व्यवसाय रहता है। तीस वर्ष तक यौवन तथा चालीस वर्ष तक सर्वधातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य, पौरुष, स्मरण-शक्ति, वाङ्मयशक्ति एवं, विज्ञानशक्ति के आश्रित गुणों की सम्पूर्णता हो जाती है; तत्पश्चात् ये इसी अवस्था में ६० वर्ष तक बने रहते हैं।

महर्षि काश्यप ने धातु, बल, वीर्य, सत्त्व एवं पराक्रम की वृद्धि की युवा अवस्था ३४ वर्ष तक, तदुपरांत धातुओं की स्थिरता के साथ ७० वर्ष तक मध्यमावस्था मानी है।

महर्षि हारीत ने इस अवस्था को दो भागों में विभक्त किया है युवा एवं मध्यमावस्था। इसमें २५ वर्ष तक युवावस्था तथा सत्त्व वर्ष तक मध्यमावस्था मानी है। इस अवस्था में भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक कार्यक्षमता की दृष्टि से पुनः उत्तम, मध्यम एवं अधम अवस्था की कल्पना की है, अर्थात् बाल, युवा एवं मध्यम अवस्था वाले तथा सुकुमार व्यक्ति मध्यम संज्ञक; सोलह से बीस वर्ष की आयु में भी कृश स्त्री-पुरुष तथा परिपूर्णावस्था में भी ऐसे ही रहने वाले मध्यम आयु वाले अधम संज्ञक; पच्चीस वर्ष से पचास वर्ष तक कठोर कर्म करने वाले स्त्री-पुरुष एवं सत्तइस वर्षोपरान्त पचास वर्ष तक बालों की वृद्धि होने वाले उत्तम संज्ञक होते हैं। स्थूल, अति लम्बा तथा कठोर पुरुष या बड़े पैटे वाली स्त्री उत्तमोत्तम संज्ञक कहलाती है।^१ शरीरस्थान में पुनः आयु का वर्णन करते हुए इस मध्यमावस्था को प्रौढ़ एवं प्रालम्ब दो भागों में विभाजित किया है, पर इसकी कोई आयु-मर्यादा नहीं वर्णित की।^२

During this stage energy, potency, strength, working capacity, understanding, retention power, memory, vocabulary, analysing capacities and all the *dhātus* are fully developed and mature, psychology is stable. There is no decline in the qualities of *dhātus*. This span is dominated by *pitta*.

Caraka and Vāgbhata keep the age limit of this span upto sixty years, while Sūśruta, Kāśyapa and Hārīta to seventy years.

Various authors have subdivided this span in following way:

(a) Sūśruta-*Yrdhā* (developmental stage) upto twenty years; *yauwana* (adult age) upto 30 years, *sampūrṇatā* (full maturity) upto forty years and slight *hāni* (decline) upto seventy years.

(b) Vāgbhata-*Yauwana* upto 30 years, *sampūrṇatā* upto forty years and *aparīṇāni* (no decline) upto sixty years.

(c) Kāśyapa-*Yuvāwasthā* upto forty years then *madhyamāwasthā* (middle age) upto seventy years.

(d) Hārīta-*Yuvāwasthā* upto twentyfive, *madhyamāwasthā* upto seventy years. He has further classified it on the basis of health and working capacity, as *utrama* (excellent), *madhyama* (average) and *adhama* (low). Children, young or middle aged and soft persons

१.पञ्चविंशो युवा नः। मध्यमं सप्तविर्यावत्..... ॥ ४॥

तथा च सुकुमारश्चेत्येते मध्यमसंज्ञकाः। वयसः षोडशमधिकं समग्रं च भवेत्तु यः ॥ ५॥

आविशति समाः प्राप्ते यथा च कृशदेहवान्। पूर्णं वयः त्रिंशः प्राप्ता मध्यमे चाधमं वयः ॥ ६॥

पञ्चविंशत्समावृत्तमपञ्चाशदातः पुनः। कर्मकठोरं वनिता दुश्यते चोत्तमं वयः ॥ ७॥

सप्तविंशत्समावृत्तं पञ्चाशत्संयुताः समाः। बालवृद्धिस्तथा यस्य इत्येतदुत्तमं वयः ॥ ८॥

स्थूलोऽतिदीर्घकठिनस्तथा स्त्री बृहदीदाया। इत्युत्तमोऽवयववाञ्छालव्यक्षोत्तमोत्तमः ॥ ९॥ (हो० सं० प्र० स्थानो ५/४ से ९)

२. चतुर्विधं शरीरं प्रौढ़ं प्रालम्बकम्। (हो० सं० य० स्थानो १/३)

are *madhyama*, emaciated even at the age of sixteen or twenty years and who maintain same health upto full maturity along with middle aged persons are *utthama*; persons doing very hard work in between twenty-five to fifty years of age, having growth of hair even between twentyseven to fifty years are the *utthama* persons. Tall, fat, stout males and females of big belly are categorized as *utthamottama* (best).

(इ) वृद्धावस्था (Old age)

यह अवस्था ६० या ७० वर्षोपान्त सामान्य क्षयावस्था की है, इसमें वायु का प्राधान्य रहता है। स्त्री-शरीर की रजःस्राव एवं प्रजननादि क्रियाओं से इस अवस्था का सम्बन्ध न होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं दिया जा रहा है।

This age starts after sixty or seventy years and is dominated by *vāyū*. Since menopause occurs before beginning of this stage, hence, it is not being described in detail here.

स्त्री-शरीर की विशिष्ट अवस्थाये (Specific epochs of woman's life)

पूर्व पृष्ठों का वर्णन सामान्य दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए दिया गया है, परन्तु ऐसा देखा जाता है कि स्त्री की प्रजनन-शक्ति सम्पूर्ण मध्यमावस्था में नहीं रहती, बल्कि इसी अवस्था में रजोनिवृत्ति हो जाती है। स्त्री बालावस्था की अंतिम सीमा अर्थात् १६ वर्ष की अवस्था में पूर्ण वीर्य वाली होकर संभोग एवं गर्भाधान-योग्य हो जाती है। महर्षि काश्यप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आरोग्य एवं आहारदि सामान्य हों तो यह पूर्णता या गर्भाधान-योग्यता की अवस्था इसके पूर्व भी आ सकती है।^१ सम्भवतः गर्भाधान-क्षमता को दृष्टिगोचर करते हुए आचार्य भावमिश्र ने स्त्री की मध्यमावस्था को 'तरुणी ३२ वर्ष तक एवं अधिरुद्धा ५० वर्ष तक' इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया है।

महर्षि हारीत ने पाँच वर्ष तक की कन्या को बाला, आगे ६ वर्ष तक की बालिका को (अर्थात् ११ वर्ष की अवस्था तक) मुधा अवस्था बाराह वर्ष की अवस्था तक बाला एवं आगे ७ वर्ष (अर्थात् १९ वर्ष की अवस्था) तक मुधा की संज्ञा दी है। इसके बाद नौ वर्ष (अर्थात् २८ वर्ष) की अवस्था तक प्रौढा, बाद के तेरह वर्ष (अर्थात् ४१ वर्ष) की अवस्था तक प्रातरमा कहलाती है। इसके बीच २४ वर्ष से ३७ वर्ष तक मध्यमावस्था की स्त्री पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है, यह उत्तम अवस्था है। उपर्युक्त वर्णन में महर्षि हारीत ने बाला एवं मुधा की दो विभिन्न अवस्थाये दी हैं, सम्भवतः देश, जाति एवं काल आदि के भेद के कारण यह अन्तर आया होगा।

१. (अ) पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥ (सु० सं० सू० ३५/१३)
(आ) तस्यां षोडशवर्षायां॥ (अ० सं० शा० १/४)
(इ) ऊनषोडशतीतसप्ततिवर्षस्या (अ० सं० शा० १/२१)
(ई) पूर्णषोडशवर्ष स्त्री॥ (अ० ह० शा० १/८)
(उ) षोडशवर्षयोर्हि॥ (का० सं० शा० ५/४)
२. अत्रापि यदाहारविशेषादपरोयाच्च पूर्णं भवति इति परिच्यते ॥ (का० सं० शा० ५/४)
३. बालेति गोयते नारी यावद्वर्षाणि षोडश । ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वाविंशद्वत्सरावधि ॥
तदूर्ध्वमाधिरुद्धा स्यात्पञ्चाशत्तत्सरावधि । वृद्धा तत्पते ज्ञेया सुतोत्सववर्जिता ॥ (भा० प्र० पूर्व० ५/२८१ व २८२)
४. पञ्चवर्षा स्मृता बाला मुधा च षट्समावर्षिम् । द्वादशाब्दं स्मृता बाला मुधा स्यात्सप्तमावर्षिम् ॥
प्रौढा च नवर्षाणि प्रतरमा च त्रयोदश । चतुर्विंशद्वर्षादूर्ध्वं सप्तविंशति मध्यागाः ।
पूर्णे वयः स्त्रियः प्राज्ञा इत्येतदुत्तमं वयः ॥ (हो० सं० प्र० स्था० ५/१३ व १४)

धर्मशास्त्र की पुस्तक पराशर स्मृति में बाला की अवस्था को आठ वर्ष तक गौरी, नव वर्ष तक गौहिणी, दस वर्ष तक कन्या एवं उसके उपरान्त रजस्वला की संज्ञा दी है।^१ ऐसा प्रतीत होता है की महर्षि हारीत एवं आचार्य भावमिश्र ने स्त्री की इन विशिष्ट अवस्थाओं का वर्णन तत्कालीन साहित्य में वर्णित नायिका या मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है; यद्यपि आयुर्वेदिक आचार्यों ने इसमें आयु की सीमा का भी वर्णन कर दिया है, जो समुचित प्रतीत नहीं होता। स्त्री की अवस्थाओं का विभाजन उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों विशेषकर अंगरसों की न्यूनाधिक्यता के आधार पर पुरान-शरीर-वर्णित स्थितियों के समकक्ष हो करना चाहिए जो निम्नोक्त प्रकार से हो सकता है।

तालिका ३ आयु का विभाजन	
पुरुष	स्त्री
बाल्यावस्था बालावस्था-१६ वर्ष	बाल्यावस्था बाला-१० वर्ष कुमारी-१० से १२ वर्ष रजोमती-१२ से १६ वर्ष
मध्यमावस्था वृद्धि-१६ से २० वर्ष युवा-२० से ३० या ३४ वर्ष सर्वधातु-सम्पूर्णता-३० से ४० या ६० वर्ष क्षय-प्रारम्भ-४० से ७० वर्ष (केवल सुष्ठुत)	मध्यमावस्था युवती-१६ से ४० वर्ष प्रौढा-४० से ५० वर्ष वृद्धा-५० वर्ष के बाद

सामान्य अवस्था विभाजन में भी आचार्य चरक ने मध्यमावस्था ६० वर्ष तक एवं सुष्ठुत ने ७० वर्ष तक मानी है तदुपरान्त वृद्धावस्था मानी गई है। विज्ञेयों में आचार्य भावमिश्र ने ५० वर्ष के बाद वृद्धावस्था मानी है। चूँकि सामान्यतः इस आयु तक स्त्री को रजोनिवृत्ति हो जाती है अतः मध्यमावस्था की सीमा ५० वर्ष तक रखना अधिक युक्तिसंगत है।

Preceding description relates to both sexes, but in females the reproductive capacity does not last even for the whole middle age, rather menopause ensues. In the last few years of childhood itself woman is fully mature to achieve conception, this maturity can come even earlier if she is free from diseases and has good diet. Bhāva-miśra has mentioned the woman as *karuṇā* (ever young) upto thirtytwo years and *adhiṛuḍhā* (middle aged) upto fifty years, after which she is *vidhā* (old lady).

Hārīta has classified the age of female as *bālā* upto five years followed by *mugdā* for another six years (upto 11 years) or *bālā* up to twelve years followed by *mugdā* for another seven years (upto 19 years; this difference might be due to individual variation), *prauḍhā* upto 28 years and *pragalbhā* upto 41 years. In between twentyfour to thirtyseven she is in best age. Parāśara smṛti has mentioned a girl upto 8 years as *gaurī*, upto nine as *rohini*, upto ten as *kanyā* followed by *rajastwālā*. It seems that this classification is based on the prevalent socio-religious conditions thus, is not suited to our purpose.

१. अष्टवर्षा भवेत् गौरी नववर्षा तु गौहिणी । दशवर्षा भवेत् कन्या अत ऊर्ध्वं रजःस्वला ॥ (पराशर स्मृति ७/६)

The specific life span of female should be dealt-with on the basis of her reproductive capacity or hormonal status maintaining parity with general description, which is given in tabular form as under-

Division of Age	
Male	Female
Childhood: upto 16 years	Childhood: (a) <i>Bālā</i> —10 years (b) <i>Kumārī</i> —10 to 12 (c) <i>Rajomati</i> —12 to 16 years
Middle age: (a) <i>Yuddhi</i> —16 years (b) <i>Yuvā</i> —20 to 30 or 34 yrs. (c) <i>Dhātū</i> maturity—30 to 40 or 60 yrs (d) Beginning of decline—40 to 70 yrs. (only <i>Suśrūta</i>)	Middle age: (a) <i>Yuvati</i> —16 to 40 yrs. (b) <i>Praudhā</i> —40 to 50 yrs. (c) <i>Yuddhā</i> —50 yrs onwards.

स्त्री की आयु की विभिन्न अवस्थाओं में दोषों की स्थिति (Status of doṣas in these epochs of woman's life)

शरीर में तीनों दोष हर समय उपस्थित रहते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में तर-तम का भेद होता है। पूर्व युद्ध में वर्णित बाला एवं मध्यमावस्था के समस्त उपायों में स्त्री-शरीर की दृष्टि से दोषों की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्यम्भावी है, क्योंकि आर्तव के आनेय होने के कारण उसकी उत्पत्ति-काल में शरीर में तेज-महाभूत की वृद्धि होती, जिसके कारण पुरुष की अपेक्षा स्त्री में पित्त का प्राधान्य कुछ पहिले हो जायगा। दोषों की संभावित स्थिति निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

तालिका ४				
आयु की अवस्थाओं	अवस्थाओं के उपवर्ग	आयु-सीमा	शारीरिक-परिवर्तन	दोष-स्थिति
बाल्यावस्था	१. बाला (गौरी, रोहिणी, कन्या, बाला आदि)	१० वर्ष	सर्वांगीण शारीरिक वृद्धि	कफोत्पन्न, पित्त एवं वायु हीन
	२. कुमारी (रजोदर्शन पूर्विकावस्था या मुधावस्था)	१० से १२ वर्ष	स्नान एवं योगि-वृद्धि आदि	कफोत्पन्न, पित्त मध्य एवं वायु हीन
	३. रजोमती (रजोदर्शनावस्था या रजस्वला, सम्पूर्ण वीर्य की अवस्था या मुधावस्था)	१२ से १६ वर्ष	रजोदर्शन प्रारम्भ एवं पूर्णरूपेण उपस्थित, स्त्री गर्भाधान-योग्य (अंतिम चरण में)	कफपित्तोत्पन्न एवं वायु हीन

मध्यमावस्था	१. युक्ती (वृद्धि की अवस्था, यौवनावस्था, तरुणी एवं प्रौढ़) या प्रारम्भा	२. प्रौढ़ावस्था (अधिकृता या प्रारम्भा)	३. वृद्धावस्था	वृद्धावस्था
१६ से ४० वर्ष तक	४० से ५० वर्ष	५० वर्ष के बाद	५० से ५५ वर्ष के बाद	वर्ष के बाद
उच्चतम प्रजनन-शक्ति, सर्वांगीण-वृद्धि एवं सम्पूर्णता	अल्प प्रजनन-शक्ति, रजोनिवृत्ति के लक्षण प्रारम्भ	रजोनिवृत्ति	सर्वांगीण क्षय की अवस्था	पित्तोत्पन्न, कफ मध्य एवं वायु हीन पित्तोत्पन्न, वायु मध्य एवं कफ हीन वातोत्पन्न, पित्त मध्य एवं कफ हीन वातोत्पन्न, पित्त एवं कफ हीन

All the three *doṣas* are always present in the body, but relative predominance changes in different conditions or ages. *Ārava* being *āgneya* in character is likely to increase *tejas mahābhūta* of the body, which may cause increase in the amount of *pitta* relatively in earlier age than seen in males. Considering this aspect, probable status of *doṣas* may be considered in following way—

Status of doṣas in different epochs of life				
Classification of age	Subclassification	Age limit (yrs)	Changes in the body	Status of Doṣas
Childhood	1) <i>Bālā</i> (<i>gaurī, rohinī, kanyā and bālā</i> etc.) 2) <i>Kumārī</i> (premenarche or <i>mugdhā</i>)	10 10 to 12	General development. Development of secondary sex characteristics	<i>Kapha</i> +++ <i>Pitta</i> and <i>Vāyu</i> + <i>Kapha</i> +++ <i>Pitta</i> ++ <i>Vāyu</i> +
Middle Age	3) <i>Rajomati</i> (menarche established, maturity stage or <i>mugdhāwasthā</i>) 1) <i>Yuvati</i> (<i>yuvā, tarunī or praudhā</i>) 2) <i>Praudhāwasthā</i> (<i>adhivādhā</i> or <i>pragalbhā</i>)	12 to 16 16 to 40 40 to 50	Menstruation starts and cycle is fully established, she is capable to conceive. Maximum reproductive capacity, full maturity. Premenopausal symptoms evident	<i>Kapha</i> +++ <i>Pitta</i> +++ <i>Vāyu</i> + <i>Pitta</i> +++ <i>Vāyu</i> ++ <i>Kapha</i> +

cont.

3) <i>Yrdhā</i>	50 onwards	Menopause	<i>Vāta</i> + + + <i>Pitta</i> + + <i>Kapha</i> +
Old age <i>Yrdhā</i>	After 50 or 55	General decline	<i>Vāta</i> + + + <i>Pitta</i> + <i>Kapha</i> +

ऋतुसावादि के द्योतक विभिन्न शब्द (Different words used to denote menstrual blood and ovum etc.)

विषय का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ऋतुसाव, ऋतुचक्र एवं स्त्रीबीज को परिलक्षित करने के लिए संहिताओं में यत्र-तत्र विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है। चूँकि इन शब्दों के सन्दर्भ-भेद से ही भिन्न-भिन्न अर्थ करने होते हैं, अतः विषय में अप्रसर होने के पूर्व इस शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है।

Certain words have been used to describe menstrual blood and ovum. Their specific connotation is to be taken with reference to context. This terminology is described as follows—

(अ) रजःसाव एवं स्त्रीबीज को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न शब्द (Words used to describe menstrual blood and ovum)

रजःसाव एवं स्त्रीबीज को प्रदर्शित करने के लिए संहिताओं में आर्तव, शोणित, असृक्, रज, रक्त, लोहित आदि शब्दों का; केवल रजःसाव को परिलक्षित करने के लिए सधिर एवं पुण्य तथा स्त्रीबीज के लिए बीज शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्रिम पंक्तियों में इन रजःसाव शब्दों के दोनो अर्थों (रजःसाव एवं स्त्रीबीज अर्थ) में प्रयुक्त कुछ सन्दर्भ विषय के स्पष्टीकरण की दृष्टि से उद्धृत किये जा रहे हैं। इन सभी सन्दर्भों का विस्तृत विवरण स्वस्थानों पर आगे, अतः यहाँ पर केवल संकेत मात्र ही किया जा रहा है। यद्यपि टीकाकार अरुणदास ने आर्तव शब्द से रजःसाव ग्रहण करने का स्पष्ट निर्देश किया है^१ परन्तु सन्दर्भ-भेद से अस्पष्टाहृदयकार ने आर्तव से स्त्रीबीज आदि भी माना है, क्योंकि रजःसाव के रक्त से गर्भाधान न हो, शुक्र के साथ स्त्रीबीज (आर्तव) मिलकर गर्भ का निर्माण करता है।

Ārāva, *śonita*, *asṛk*, *raja*, *rakta*, *lohita* etc. words are used in the classics to denote menstrual blood or ovum at different places, while *rudhira* and *pūṣpa* denote only menstrual blood and *bīja* is used for ovum. Though commentator Arunadatta has specifically indicated to consider menstrual blood with word *ārāva*, yet, in A.H. word *ārāva* is used to denote ovum also. In subsequent description only references are cited, details are given at respective places.

(१) आर्तव (Ārāva)

(अ) रजःसाव के लिए (for menstrual blood)

वह (वायु) प्रकुपित होकर आर्तव का अवरोध कर देती है, आर्तव का विमोचन होते ही तत्क्षण सुखानुभूति होती है। ऋतौ भवचर्मावर्णम्, स्त्रीणां यद्वपस्मार्गात् शुद्धमीषत् कृष्णं निगन्धं च वायुप्रेरितं लोहितं प्रवर्तते तदार्तवमुच्यते।

(अ० ह० शा० ११/१/को० अरण्य० टीका०)

ऋतुचक्र एवं उसका शरीर-क्रिया विवेचन

है; न बहुत अधिक, न बहुत अल्प, इन्द्रगोप के वर्ण का आर्तव शुद्ध होता है आदि अनेकों स्थलों पर आर्तव शब्द रजःसाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है।^१

The *vāyu* getting agitated, obstructs the *ārāva*; discharge of *ārāva* brings immediate relief, neither too less, nor too much, resembling *indragopa* in colour is pure *ārāva*, in similar number of places the word *ārāva* is used to denote menstrual blood.

(आ) स्त्रीबीज के लिए (for ovum)

शुक्र एवं आर्तव के सम्मिश्रण (गर्भ) को वायु विभाजित करती है, उचित पथ से गर्भाशय में (शुक्र) प्रविष्ट होकर आर्तव से अभिसंसर्ग को प्राप्त होता है, इसी भाँति के गर्भाधान या गर्भ से सम्बन्धित अनेकों स्थलों पर आर्तव शब्द का प्रयोग स्त्रीबीज (ओवम) को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है।^१

The word *ārāva* is used to connote ovum at number of places in relation to fertilization or zygote/embryo/fetus i.e. *vāyu* divides the combination of *sūkṛa* and *ārāva*; *sūkṛa* after entering uterus through appropriate passages gets admixed with *ārāva* etc.

१. स प्रकुपिते..... आर्तवमुपरुणद्धि..... तदार्तवमुपरुण्यमानं (च० सं० नि० ३/१४); अर्तवे सा विमुक्ते तु..... (च० सं० चि० ३०/२६); नैवातिबहु नात्यल्पमार्तवं शुद्धमतिशेता इन्द्रगोपकम्पङ्कसमार्तवं शुद्धमतिशेता (च० सं० चि० ३०/२५-२२६)। योनिमभिप्रपन्नाः..... योनिमुपपन्न्यार्तवञ्च। (सु० सं० नि० २/१७)। आर्तवमपि निभिदधैः शोणितचतुर्धैः..... (सु० सं० शा० २/५); तदार्तवं प्रशंसति..... (सु० सं० शा० २/१७); दोषैष्वतृमार्तव्यादार्तवं नश्यति (सु० सं० शा० २/२१)। ऋतुलाता..... आर्तवं वायुपदाया (सु० सं० शा० २/४८); ऋतुसु..... दृष्टार्तवः। अर्तुद्वार्तवमि..... (सु० सं० शा० ३/६); मासेनोपचितं..... धमनीभ्यां तदार्तवम्। (सु० सं० शा० ३/१०); गृहीत..... आर्तवकानां..... गृहीतार्थयोगमार्तव। (सु० सं० शा० ४/२४); वच्च्यां नष्टार्तव। (सु० सं० शा० ३/८१)। अनातवस्तना षण्डी..... (सु० सं० शा० ३/८१); शुक्रार्तवद्वयो दोषाः..... (सु० सं० शा० ३/८३)। तथा रक्तमेव च..... प्रवर्तमानमार्तवित्पाद्युः। (अ० सं० शा० १/१०); तद्व कदाचिद्वर्तव..... (अ० सं० शा० १/१६); आर्तवमपि शुक्रवदधैः..... (अ० सं० शा० १/२५); तत्रावाचीन शुक्रार्तवद्वयोः..... (अ० सं० शा० १/२६)। तथा प्रप्यार्तवे..... (अ० सं० शा० १/३७)। कुणपप्यार्तवे..... (अ० सं० शा० १/३८)। सर्वेषु शुक्रार्तवद्वयोषु..... इत्येव विशुद्धशुक्रार्तवो.....। ऋतुसु दृष्टार्तवो..... (अ० सं० शा० १/३९, ४०); तस्मात्ततः परमार्तवं न दृश्यते..... (अ० सं० शा० २/१०);..... गर्भकोष्ठार्तवोपगमन..... (अ० सं० नि० ११/४४); योन्त्यामुपगुप्रविश्यार्तवमुपरुणद्धि..... (अ० सं० नि० ११/४५); तैःशर्त्ति..... भगार्तवम्। (अ० सं० शा० ३/८१०); केनितारण..... रूक्षार्तवद्वयम्। (अ० सं० शा० ३/८३); पुशोष..... सितार्तवम्। (अ० सं० शा० ३/८४)। निरुणद्ध्यार्तवं योन्त्यां..... (अ० सं० नि० ११/५०);..... तनुरूक्षार्तवसुतिम्। (अ० सं० शा० ३/३३०)। नीलपीतसितार्तवम्। (अ० सं० शा० ३/३३/४३)।

२. भिनन्ति यावद्बहुधा प्रपन्नः शुक्रार्तवः। (च० सं० शा० २/१४); उचितेन पथा गर्भाशयमुप्रविश्यार्तवेनाभिसंसर्गमिति॥ (च० सं० शा० ४/७); तथाऽपि आर्तवोत्तर्तिर्भक्त एव भवति। (च० सं० शा० ४/३० की चक्र० टी०)। रक्तलक्षणमार्तवं गर्भकृत्वा। (सु० सं० शा० १/५५); एवमुदुशुक्रः शुद्धार्तवो च॥ (सु० सं० शा० २/२४); सौम्यं शुक्रमार्तवमानेयम्..... (सु० सं० शा० ३/३); संसृज्यते चात्तेवना। (सु० सं० शा० ३/४)। अथ शुद्धशुक्रार्तवमसौ..... (अ० सं० शा० १/२२)। शुद्धयोनिगर्भाशयार्तवया..... (अ० सं० शा० १/४०)। महाभूतैरुत्पन्नमार्तवेनाभूमूर्च्छितम्..... (अ० सं० शा० २/३); शुक्रार्तवेऽनिलेन..... (अ० सं० शा० २/६); आर्तवस्य च दोषेण..... (अ० सं० नि० ११/३३)। शुद्धे शुक्रार्तवे सत्तवः..... (अ० सं० शा० १/१)। शुद्धशुक्रार्तवं स्वस्थं..... (अ० सं० शा० १/१९)।

(२) शोणित (*Śonita*)(अ) स्त्रीबीज के लिए (*for ovum*)

शुद्ध योनि, शोणित एवं गर्भाशय युक्त स्त्री; शुक्र एवं शोणित का गर्भाशय के अन्तर्गत संसर्गः शुक्र एवं शोणित बीज हैं; शुक्र, शोणित एवं जीव का संयोग आदि अनेकों गर्भाधान या गर्भ से सम्बन्धित स्थलों पर शोणित शब्द का प्रयोग स्त्रीबीज (ओवम) को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है।^१

The word *śonita* is used to denote ovum at number of places in relation to fertilization or zygote/embryo/fetus i.e. the woman possessing healthy yoni, *śonita* and *garbhāśaya*; union of *śūkra* and *śonita* inside the uterus; *śūkra* and *śonita* are the seed; union of *śūkra*, *śonita* and *jīva* etc.

(आ) रजःस्राव के लिए (*for menstrual blood*)

ऋतुस्राव से सम्बन्धित सन्दर्भों में यथा सद्योग्रहीत गर्भ में शोणित का अन्वयः; स्त्री एवं पुरुष में शोणित एवं शुक्र का प्रादुर्भाव आदि में शोणित शब्द का प्रयोग रजःस्राव के लिए किया गया है।^२

The word *śonita* is used to denote menstrual blood also at certain places i.e. cessation of *śonita* after conception, appearance of *śūkra* and *śonita* at appropriate age in male and female respectively etc.

(३) असृक् (*Asṛik*)(अ) स्त्रीबीज के लिए (*for ovum*)

गर्भाधान एवं गर्भ से सम्बन्धित स्थलों पर प्रयुक्त असृक् शब्द स्त्रीबीज (ओवम) का द्योतक है यथा असृक् का सम्प्रतः होना भी सुखी गर्भ के लिए आवश्यक, असृक् दोष से गर्भाङ्ग-विकृति आदि।^३

The word *asṛik* used in relation to fetus i.e. normalcy of *asṛik* for normal fetus, abnormality of *asṛik* a cause of teratologic abnormality etc. refer to ovum.

१. निम्नवाक्षाप्रदुष्योनिशोणितगर्भाशया शुक्रशोणितसंसर्गमन्तर्गमर्भाशयात् (च० सं० शा० ३/३);

बीज इति शुक्रशोणिते (च० सं० शा० ३/१७ को चक्र० टी०); शुक्रशोणितबीजसंयोगे (च० सं० शा० ४/५);

.....अव्यापन्नयोनिशोणितगर्भाशया (च० सं० शा० ४/७);शोणितगर्भाशयवृद्धते,शोणितगर्भाशयौ

दृश्यन्तिशोणिते गर्भाशयबीजभागाः शोणिते गर्भाशयबीजभागावयवः (च० सं० शा० ४/३०); दृष्टशोणितबीजं

नार्थाः (च० सं० चि० ३०/२९)। तस्य छत्वेन शुक्रशोणितस्याभिपच्यमानस्य (सु० सं० शा० ४/४);

शुक्रशोणितसंयोगे (सु० सं० शा० ४/६३); शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थानाविकार (सु० सं० शा० ५/३);

शुक्रशोणितं वायुनाभिप्रपन्नमवक्रान्त (सु० सं० शा० १०/५७)। यदा तु विज्याः शोणितगर्भाशयो (अ० सं० शा० २/४७)। यदा हस्त्याशोणितान्त्रे बीजे (अ० सं० शा० २/४८)। बीजशोणितव्याकाश (का० सं० शा० ३/३)।

२. तत्र सद्योग्रहीतगर्भाशया शुक्रशोणितयोरन्वयः । (सु० सं० शा० ३/१३)। स्त्रीपुरुषयोः शोणितशुक्रे।

.....शोणितशुक्रयोर्मध्ये (का० सं० शा० ५/४); वायुः शोणितमादाय वहति शोणितम् (का० सं० चि० ९/२६);प्रतिघातान् सशोणितः (का० सं० चि० ९/२७); संवृतं शोणितं तत्र (का० सं० चि० ९/२८)।

३. शुक्रासृगात्मशयकालसम्प्रतः (च० सं० शा० २/६); शुक्रासृगाहातविरादोषात् (च० सं० शा० २/७);

शुक्रासृजोर्वाङ्मुख्यते (च० सं० शा० २/१६); शुक्रास्राडननुच्यन्मन् ॥ (अ० ह० शा० १/३८)।

(आ) रजःस्राव के लिए (*for menstrual blood*)

असृक् एवं इसी भाँति के अनेकों स्थलों पर प्रयुक्त असृक् शब्द रजःस्राव का द्योतक है।^१

The term *asṛik* used in *asṛigdava* and similar conditions refers to menstrual blood.

(४) रज (*Raja*)(अ) स्त्रीबीज के लिए (*for ovum*)

माता, पिता रज एवं शुक्र के माध्यम से पञ्चमहाभूतों का गर्भ में आगमन आदि स्थलों पर रज शब्द स्त्रीबीज (ओवम) के लिए प्रयुक्त है।^२

The word *raja* for ovum is used in certain references i.e. mother, father, *rāja* and *śūkra* as a source of *mahābhūtas* in fertilization etc.

(आ) रजःस्राव के लिए (*for menstrual blood*)

रज का अधिक प्रदोषण आदि सन्दर्भों में रज शब्द रजःस्राव का द्योतक है।^३

Excess discharge of *rāja* etc. references denote it to be menstrual blood.

(५) रक्त (*Rakta*)(अ) स्त्रीबीज के लिए (*for ovum*)

रक्त का विदाह, रक्त का पीड़न, रक्त को शुद्धता, रक्त से शुक्र का परिवेष्टन आदि गर्भ या गर्भाधान से सम्बन्धित सन्दर्भों में रक्त शब्द स्त्रीबीज के लिए प्रयुक्त हुआ है।^४

१. असृक्निरुद्धं पक्वेन नार्थाः तदासृगास्त्रि। दृष्टाऽसृगेकं न च गर्भसंसर्गः । १। (च० सं० शा० २); तस्मात्सुन्दरं

प्राहुः (च० सं० चि० ३०/२०८)। एवं विभिन्न दोषिक असृक् के लक्षणों में। असृक्दरं विजनीयात् असृक्दो

भवेत् सर्वः। (सु० सं० शा० २/१८-१९); तद्वत् असृक् पुनः। (सु० सं० शा० ३/१९); सदाहं प्रक्षतसत्

यस्यां (सु० सं० उ० ३८/१२)। अतिप्रसङ्गेन तदेजसुन्दरं। (अ० सं० शा० १/१९)। शूना नीलपीतास्त्रिहातिनी (अ० सं० उ० ३८/४८)। दृष्टासृगाश्रे। (अ० ह० चि० १/५३); रक्तयोः पाण्ड्यासृगित्सुते । (अ० ह० उ० ३३/४३); नीलपीतास्त्रिहातिनी। (अ० ह० उ० ३३/४७)।

२. भूतानि मातापितासंभवानि रजश्च शुक्रं (च० सं० शा० २/३४)। सवामुद्विगेद् ... रजसपुणम्। (सु० सं० उ० ३८/१२)।

३. गते पुणणे खसि नवे (च० सं० शा० ४/७); रजः प्रदीयते यस्मात् (चि० सं० चि० ३०/२०९)। सदेव रजः सदां। (सु० सं० चि० १४/६); सफेनित रजःकुब्धेण। (सु० सं० उ० ३८/९)। योनिश्चोचन रजःस्राव इति। (अ० सं० शा० १/२९); तस्याश्च रजोवाहिनी। (अ० सं० शा० २/१०); सा फेनितं रजः। (अ० सं० उ० ३८/३६ एवं अ० ह० उ० ३३/३३); कर्णिकां रजोमाग्नियोधिनीम्। (अ० सं० उ० ३८/५१)। मासि

मासि रजः स्त्रीणां। (अ० ह० शा० १/७); वागीशान्ध्या क्षीयते रजः। (अ० ह० उ० ३३/४५);

रजोमाग्नियोधिनीं (अ० ह० उ० ३३/५०)। रजस्तलायाक्षेत्। (का० सं० शा० ५/५)। रजोवशाः सिया यस्मिन्

रजःप्रविपुञ्जन्त्यतः ॥ (का० सं० चि० ९/१७)। रजोवहः समावृतः। (का० सं० चि० ९/२९)

४. तदस्याः पीडितं विदहति रक्तं शुक्रं च। (च० सं० शा० ८/६)। वापपाश्वर्गगायाः रक्तशुक्रौ (अ० सं० शा० १/५९)। रक्ते शुक्रेऽनिते हृदि। (अ० ह० शा० १/८)। रक्तेन परिवेष्टयते। (का० सं० शा० २/११)।

Vitiation of *rakta*, obstruction/compression of *rakta*, enveloping of *sūkra* by *rakta* etc. references pertaining to fertilization or zygote refer to the use of word *rakta* for ovum.

(आ) रजःस्राव के लिए (*for menstrual blood*)

रक्त का प्रवर्तमान होना, वायु के द्वारा रक्त का परिग्रहण आदि सन्दर्भों में रक्त शब्द रजःस्राव के लिए प्रयुक्त है।

Appearance/discharge of *rakta*, withholding of *rakta* by *vāyu* etc. refer it to be menstrual blood.

(६) लोहित (*Lohita*)

(अ) स्त्रीबीज (*For ovum*)

लोहित एवं रेतस् को चेतनवान या चेतना धातु से युक्तता आदि सन्दर्भों में लोहित शब्द स्त्रीबीज के लिए प्रयुक्त है।

Association of *lohita* and *retas* with *chetanā* indicate that word *lohita* is used for ovum.

(आ) रजःस्राव के लिए (*for menstrual blood*)

स्त्री में लोहित की अवस्थिति सन्दर्भ रजःस्राव का द्योतक है।

Reference of situation of *lohita* in women indicate it to be menstrual blood.

(७) रुधिर (*Rudhira*)

रुधिर शब्द केवल रजःस्राव के लिए प्रयुक्त हुआ है यथा रुधिर का योनि में सञ्चय आदि।

The word *rudhira* is used for menstrual blood only.

(८) पुष्प (*Puspa*)

पुष्प शब्द केवल योनिपथ से होने वाले रक्तस्राव के लिए ही अनेकों स्थलों में प्रयुक्त हुआ है।

Word *puspa* is used to denote only bleeding through vaginal passage.

१. न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजं । (सु० सं० शा० २/३१); वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं । (सु० सं० उ० ४२/१४) । ततो विपर्यतेः प्रवृत्ते रक्ते । (अ० सं० शा० १/१७); मासेनोपचितं रक्तं । (अ० सं० शा० १/२३) । मासेनोपचितं रक्तं । (अ० ह० शा० १/२३) । केवल एव रक्ते । (अ० ह० शा० २/६१) । यदा रक्तवहो रक्तं । (का० सं० खिल० १/२३) ।

२. चैतनवान्तः शाश्वता लोहितरेतसो । (सु० सं० शा० १/१६) ।

३. अवस्थितं लोहितमङ्गनाया । (अ० ह० शा० २/६१) ।

४. संचितं रुधिरं योनिः । (का० सं० खिल० १/२२) ।

५. ततः पुष्पात् प्रपुति त्रियम्भामसीत । (च० सं० शा० ८/५) । पुष्पकाले शुचिस्तस्मात् । (सु० सं० शा० ३/१२) । ततः पुष्पवसने । (अ० सं० शा० १/४४); ततः स्नानात् । पुष्पदिनात् । (अ० सं० शा० १/४७) । ततः पुष्पक्षणादेव । (अ० ह० शा० १/२४); पुष्पपूर्तं हि तदैवान् । (का० सं० खिल० १/२७) ।

(१) बीज (*Biṇa i.e. ovum*)

स्त्री-शरीर-क्रिया से सम्बन्धित स्थलों पर प्रयुक्त योनि शब्द स्त्रीबीज (ओवम) का द्योतक है।

Word *biṇa* used in relation to female physiology refers to ovum.

(आ) आर्तव, रज या रक्त आदि शब्दों का कुछ अन्य अर्थों में प्रयोग (*Other substances for which these words are used*)

(१) गर्भ की लिङ्गोत्पत्ति के कारणभूत (*Factor responsible for formation of sex of embryo*)

संहिताओं में गर्भ की लिङ्गोत्पत्ति के लिये आर्तव, रज, रक्त एवं शुक्र को कारणभूत माना गया है, आचार्यों ने लिखा है कि शुक्र की बहुलता से पुत्र एवं आर्तव, रज या रक्त के बाहुल्य से पुत्री की उत्पत्ति होती है। इसका आधुनिक विषय से सामञ्जस्य बहुत ही कठिन है।

Predominance of *ārava*, *rakta* or *raja* of female and *sūkra* of male gives rise to birth of female and male respectively. Congruity of these with any substance known to-day is not possible.

(२) स्त्री-शरीर से संभोग के समय होने वाले स्राव के लिए (*For excretion during coitus*)

श्रुतिपिण्डो यथैवाग्निमाश्रितः प्रविलीयते । विसर्पयार्तवं नार्यास्तथा पुंसं समागमे॥ (सु० सं० शा० २/३६) जिस प्रकार अग्नि के आश्रित होने पर घृत द्रवीभूत होता है, उसी प्रकार पुरुष के समागम से स्त्रियों में आर्तव प्रसरण करता है।

टीकाकार डल्हण ने इस श्लोक का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि पुरुषार्तव तीन दिवस रजःस्रावकाल में संचित हो जाता है। नवीनार्तव अल्प एवं घन होने के कारण प्रवर्तन में अक्षम होता है, एवं समागम-काल में इन्द्रियद्वय के घर्षण से उत्पन्न ऊष्म के कारण विलीन हो उपसर्पित हो शुक्र एवं जीव के साथ मिल गर्भोत्पत्ति करता है। यह आर्तव ऋतुकाल में उत्पन्न होने वाला शोणित है। इसी वान में आगे इन्होंने वृद्ध वायुध का उद्धरण देते हुए समागम के समय स्त्री-शरीर से शुक्र का भी क्षरण माना है जो गर्भ के लिए अनुपयोगी है; अतः आचार्य डल्हण इस आर्तव को स्त्रीबीज मानते

१. बीजेन कन्यां च सुतं । (च० सं० शा० २/१२); बीजात् समाशुदुपगतबीजात् । (च० सं० शा० २/१८); बीजानकमश्रियकालादेषैः । (च० सं० शा० २/२१); यस्य यस्य हृद्भावयस्य बीजे बीजभागा उपततोभवति । (च० सं० शा० ३/१७); जायते बीजदोषाच्च । (च० सं० वि० ३०/८); बीजदोषात् गर्भस्य । (च० सं० वि० ३०/२४) । बीजेऽन्तर्वायुनिभे । (सु० सं० शा० २/३७); जायते बीजदोषाच्च । (सु० सं० उ० ३८/६) । मातृजस्यवयवस्य बीजे बीजंशे वा । (अ० सं० शा० २/४७); यदाह्वस्याः बीजे गर्भार्णस्ये । (अ० सं० शा० २/४८) । निर्वर्तका ये बीजांशेऽस्तेषाम् । (अ० सं० शा० २/५०); दुष्टार्णवात्प्रवृत्तबीजादोषेण । (अ० सं० उ० ३८/३२) । स्त्रीगर्भे बीजदोषतः । (अ० सं० उ० ३८/४२) । दुष्टार्णवात् बीजादोषेण दैवतः । (अ० ह० उ० ३३/२८); स्त्रीगर्भे बीजदोषतः । (अ० ह० उ० ३३/३१) ।

२. च० सं० शा० २/१२, १३; सु० सं० शा० ३/५; अ० सं० शा० १/५० तथा शा० २/५ एवं अ० ह० शा० १/५ ।

३. ननु पुरुषमार्तवमुपचयाद् दिनत्रयं सुखा स्वयमेव विनिवृत्तं त्वत्वं स्थानीभूतिविवर्तितमक्षं तत् कथमार्तवसञ्ज्ञाये येन तत्समुष्टं शुक्रं गर्भजननसमर्थं भवतीत्याशङ्क्याह-युल्लिख्यते । पुंसं समागमे इन्द्रियद्वयसंघर्षेनोपपन्ना विलीनमार्तवं विसर्पति । तच्च विसर्पितं शुक्रोपगतं गर्भशयमनुग्राहं बीजोपगतं गर्भसम्भवहेतुर्भवति । आर्तवमुत्पन्नकालं शोणितं, शुक्रमप्यगतां पुंसं समागमे क्षति, न तु तत्रोपयोगीति तत्क्षरप्रतिपादनं न युक्तम् । तथा च वृद्धवाग्भट-शोभितोऽपि । (सु० सं० शा० २/३६ की डल्हण टी०)

है। विद्वद्गणों को भी इस मत से सहमत है^१।

वैज्ञानिक तथ्यों से अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि मानव जाति में सम्भोग से स्त्रीबीज के क्षरण में कोई भी प्रभाव पड़ता हो, अतः इस आर्तव को स्त्रीबीज मानना युक्तिसंगत नहीं होगा। टीकाकार डल्हण सम्भोग के समय गर्भ के लिए अनुपयोगी शुक्र का भी क्षरण मानते हैं। एक ही क्रिया (सम्भोग) से शुक्र एवं आर्तव दोनों का क्षरण भी युक्तिसंगत नहीं है; अतः इस आर्तव से यहाँ पर सम्भोग के समय स्त्री-प्रजननांग से होने वाले अन्य साव ही अभिप्रेत प्रतीत होते हैं।

As butter melts in contact with fire, similarly woman secretes *ārava* during coitus with male. Dalhana has explained that *purvārava* is excreted during three days of menstrual blood loss. *Nayārava* being less and solid can not come out, but due to heat generated during coitus it is melted, excreted and gets mixed with *śukra*, thus, initiates conception. Further he quotes Vagbhata and says that woman secretes *śukra* during coitus which is useless for conception. Probably Dalhana refers to this *ārava* as ovum, which is accepted by Chhāṇkara ji.

In human being coitus does not initiate ovulation, thus, it is not advisable to accept *ārava* or *śukra* excreted during coitus as ovum, this may be considered only as local discharges of female reproductive system coming out during coitus.

(३) गर्भावस्था के समय होने वाले रक्तसाव के लिए (For bleeding during pregnancy)

संहिताओं में पुष्प, रक्त, शोणित, आर्तव आदि शब्द गर्भावस्था के समय होने वाले रक्तसाव के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं^२।

The words 'puspa', 'rakta', 'sonita' 'ārava' etc. have been used to denote bleeding during pregnancy (as in abortions) also.

(४) स्त्री-शरीर के अंगरसों को प्रदर्शित करने के लिए (To denote ovarian hormones)

यद्यपि संहिताओं में अंगरसों का कोई स्पष्ट वर्णन प्रतीत नहीं होता, फिर भी यद्य-तत्र उपलब्ध विषय को एकत्र करने पर ऐसा आभास होता है कि महर्षियों को शरीर के प्रजनन-सम्बन्धी विशिष्ट अंगरसों का ज्ञान था, जिसे उन्होंने आर्तव, शोणित या रज शब्द से व्यक्त किया है। इस विचार की पुष्टि के लिए सम्बन्धित उद्धरण निम्नांकित हैं :-

(१) महर्षि चाभट्ट, काश्यप एवं सुश्रुत संहिता के टीकाकार डल्हण ने रज या शोणित की उपस्थिति शुक्र के सदृश बाल्यावस्था से मानी है एवं अनुद्भूत का कारण अति सूक्ष्मत्व कहा है^३। मासिकसाव का रक्त शरीर में कहीं सूक्ष्म रूप में एकत्र नहीं रहता क्योंकि इसका निर्माण गर्भाशय में प्रतिमास सूक्ष्म रक्तवाहिनियों के पूरण से होता है। यदि इस रज से स्त्रीबीज (ओवम) माना जाय क्योंकि ये शरीर में बाल्यावस्था से ही विद्यमान रहते हैं तो द्वादश वर्ष में उसकी उद्भूति सिद्ध करना कठिन होगा; क्योंकि यह अतिसूक्ष्म होने से दृष्टिगोचर नहीं होता। आचार्य चक्रपाणि ने स्पष्ट लिखा है कि जिस आर्तव की अभिव्यक्ति १२ वर्ष में होती है उसका निर्माण शरीर में गर्भकाल में ही हो जाता है^४। अतः यह बाल्यावस्था

१. सु० सं० शा० २/३८ घणोकर-टीका (पृष्ठ सं० ४१)

२. च० सं० शा० ८/२४, २५, २६; सु० सं० शा० १०/५७; अ० सं० शा० ४/३, ५, ६, ७, ११, १२, १३; अ० ह० शा० २/१

३. अ० सं० शा० १/२१; का० सं० शा० ५/४; सु० सं० सू० १४/१८ की डल्हणटीका

४. आर्तव च यद्यपि द्वादशवर्षपूर्व व्यक्त्यते, तथापीत्य आर्तवोत्पत्तिर्भकाल एव भवति।

(च० सं० शा० ४/३० की चक्र० टीका)

में उपस्थित रज आदि शब्द अतःस्त्री प्रस्थियों के सावों (ईस्ट्रोजन आदि) के ही प्रतीक प्रतीत होते हैं।

(२) महर्षि सुश्रुत ने धातु-परिणाम का वर्णन करते हुए एक मास में शुक्र की उत्पत्ति के साथ स्त्रियों में आर्तव की भी उत्पत्ति मानी है^५। आचार्य भावमिश्र ने इस वर्णन का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि स्त्रियों में एक आशय (गर्भाशय) अधिक होने के कारण आर्तव सावों तथा शुक्र आठवीं धातु होती है। स्त्रियों में गर्भोपयोगी समस्त कार्य आर्तव द्वारा सम्पन्न होते हैं, एवं बल तथा वर्ण की पुष्टि शुक्र के द्वारा होती है^६।

महर्षि शार्ङ्गधर ने शुक्र के साथ स्त्रियों में एक मास में रज की उत्पत्ति मानी है^७।

अन्य टीकाकार डल्हण ने आर्तव को रक्त-लक्षण होने के कारण रक्त के कर्म अर्थात् जीवन को इसका कर्म माना है^८।

यहाँ पर आर्तव शब्द से अतःस्त्री प्रस्थियों के सावों का बोध होता है।

(३) महर्षि सुश्रुत ने युवावस्था के प्रारम्भ में रज के उपपद्य से शनैः शनैः स्तन, गर्भाशय एवं योनि की वृद्धि का वर्णन किया है^९। आधुनिक विज्ञान में यह स्पष्ट हो चुका है कि स्तनादि की वृद्धि ईस्ट्रोजन नामक अंगरस के कारण होती है। अतः यहाँ पर रज शब्द इस अंगरस का द्योतक माना जा सकता है।

(४) महर्षि सुश्रुत ने धातुओं आदि के क्षय के लक्षण वर्णन करते समय आर्तव-क्षय से आर्तव का यथोचित काल में अवरुध, अल्पमात्रता एवं योनिवेदना आदि लक्षण बताए हैं। टीकाकार चक्रपाणित्त ने योनि-प्रदेश के अभिपूरक आर्तव के क्षय-जन्य कुपित वायु से इन लक्षणों की उत्पत्ति मानी है^{१०}। रजःसाव गर्भाशय के सम्पूर्ण मास में संचित रक्त का साव है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संवय की प्रक्रिया में अल्पता होने से ही उपर्युक्त लक्षण मिलते हैं जिस संवय के लिए दिव्यग्रन्थि के ईस्ट्रोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, अतः यहाँ इस आर्तव-क्षय से ईस्ट्रोजन की कमी को ग्रहण कर सकते हैं।

(५) महर्षि सुश्रुत एवं चाभट्ट ने अपरा-निर्माण के वर्णन में लिखा है कि गर्भ से आर्तववह स्रोतस् का मुख अवरुद्ध होने के कारण वह आर्तव ऊपर भाग में उपचरित हो अपरा का निर्माण करता है, एवं वहाँ से नचा हुआ रक्त और ऊपर जाकर स्तनों की वृद्धि करता है तथा स्तनों एवं ओष्ठ के कृष्णत्व का उत्पादक होता है^{११}। यही रक्त कफ से उपचरित हो सन्यता को प्राप्त हो प्रसूता में सन्य के रूप में हो जाता है^{१२}। गर्भाधान के कारण दिव्यग्रन्थि का सतत कार्यरत कॉर्पोस लुटिअम अपरा-निर्माण में सहायक होता है। अपरा का सूक्ष्मरूप स्वरूप भी अन्य अंगरसों के साथ मेमोजेनिक अङ्गरस का निर्माण कर पीयूषग्रन्थि एवं दिव्यग्रन्थि की सहायता से स्तनवृद्धि करता है। यद्यपि चुचुक एवं ओष्ठ आदि की कृष्णता

१. एवं मासेन रसः शुक्र स्त्रीणां च आर्तवं भवति। (सु० सं० सू० १४/१४)

२. स्त्रीणां गर्भोपयोगि स्यादार्तवं सर्वसम्पत्ता। तासामपि बलं वर्णं शुक्रं पुष्टिं करोति हि॥

एतेन स्त्रीणां सम्पत्ते धातुवर्तव्यं शुक्रमप्यभिधत्तं बोधितम्। आशयाधिश्रवत्॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/१८८)

३. पाण्डितः पितृत्वापेन रसाद्या धातवः क्रमात्। शुक्रत्वं यस्मिन् मासेन तथा स्त्रीणां रजो भवेत्॥ (शा० सं० पूर्व० ६/१०)

४. चकारात् रक्तकमपि जीवनसंज्ञं करोति। (सु० सं० सू० १५/५ की डल्हण टीका)

५. सु० सं० सू० १४/१८

६. आर्तवक्षये यथोचितकालादर्शमल्पता वा योनिवेदना च। (आर्तवक्षय इत्यादी योनिवेदना तद्देशाभ्युपकारवक्षयकुपितेन वायुना-चक्र०) (सु० सं० सू० १५/१२ एवं चक्रपाणि टीका)

७. सु० सं० शा० ४/२४; अ० सं० शा० २/१०, ११

८. सु० सं० शा० ४/२४ की डल्हण टीका; अ० सं० शा० २/१२

में मुञ्जतः मिलितान का प्रभाव होता है पर ईस्युजन भी इस लक्षण के सम्पादन में सहायक होता है, अतः यह वर्णन भी अंगरसों के अर्थ का ही द्योतक प्रतीत होता है।

(६) सभी आचार्यों ने योनिरोगों के कारणों में आर्तव-दोष एवं बीज-दोष को माना है। समस्त योनिरोगों का अध्ययन करने पर ऐसा आभास होता है कि कतिपय व्यापद स्त्री-शरीर के विशिष्ट अंगरसों की न्यूनता के लक्षणों से सामंजस्य रखते हैं। चौक यहाँ बीज शब्द पृथक् दे दिया गया है, अतः आर्तव शब्द से अंगरसों का अर्थ ग्रहण किया जा सकता है।

(७) महर्षि चाण्ड ने आस्थापनाई व्याधियों में आर्तवनाश तथा रजःक्षय दोनों ही व्याधियों का समावेश किया है। अर्तव एवं रज दोनों ही शब्दों का एक साथ प्रयोग किसी एक शब्द के अङ्गरस परक होने का आभास देता है। स्त्रीबीज का नाश या क्षय अनुमानाय है दृष्टिगम्य नहीं, अतः यहाँ विचारणीय नहीं है।

(८) महर्षि हारीत ने बन्ध्या स्त्रियों में स्तन्य को अनुपस्थिति के कारण अर्तव को उपस्थिति का वर्णन किया है। हाइपोथैलमस, प्रोलेक्टिन के अतिरिक्त पीयूष ग्रन्थि के अन्य सभी स्त्रियों के लिए उत्तेजक पदार्थ भेजता है अर्थात् यदि हाइपोथैलमस अधिक कार्य करे तो प्रोलेक्टिन (स्तन्योत्पत्तिक अङ्गरस) नहीं आया तथा पीयूष ग्रन्थि के अन्य अङ्गरस अधिक मात्रा में हो अर्तव उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात् यह वर्णन भी अङ्गरसों का ही द्योतक है।

(९) टीकाकार चक्रपाणि ने 'रज' के भी विषय होकर व्याधि उत्पन्न का उल्लेख कर इसका अप्रत्यक्ष रूप से धातु के अन्तर्गत समावेश किया है। इस धातु रूप 'रज' को अङ्गरस का परिचायक माना जा सकता है।

Explicit description of hormones is not available in *ayurvedika* classics, however, indirect inference can be drawn from scattered references such as:-

(i) Vāgbhata, Kāśyapa and Dhaṇva accept presence of *raja* or *śonita* from the very childhood just like *śukra*, which is not visible due to very minute quantity. Menstrual blood is not accumulated anywhere in the body, rather it is formed every month in the uterus. If with this description ovum is accepted due to its presence from embryonic life, then its explicitness at twelve years of age would be difficult to explain, because it is microscopic structure. Cakrapāṇi has written that *ārtava* which is explicit at twelve years is formed in embryonic life. This reference probably indicates description of hormones specially ovarian.

(ii) Suśruta while describing the formation of *dhatūs* accepts formation of *ārtava* also alongwith *śukra* in females. Bhāvanīśra elaborating this, writes that women possess one extra *dhatu* just as presence of one extra *dāya* (*garbhāśaya*), thus, have *ārtava* as seventh and *śukra* as eighth *dhatu*. All the functions relating to conception are performed by *ārtava*, while energy and complexion etc. are promoted by *śukra*. It is also very essential for life. Here also *ārtava* refers to hormones.

१. प्रसिध्दत आर्वि गाईनिकोर्लिन (वे. कॉट पृष्ठ ११२)
२. चं० सं० वि० ३०/८; सु० सं० ३० ३८/५; अ० सं० ३०३८/३१; अ० ह० ३० ३३/२८
३. तत्वास्थाया शुक्रार्तवस्तन्यगाराजःक्षयोनाद। (अ० सं० सू० २८/१०)
४. बन्ध्यायां। क्षीरं च न भवेत्तस्मादार्तवं चाधिकं यतः ॥ (हो० सं० प्रथ० स्या० ८/१०)
५.विकारो धातुवैषम्यं । धातवो वातादयो रसादयश्च तथा रजः प्रपूतयश्च तेषां वैषम्यं।
(चं० सं० सू० १/४ को चक्र० टीका)

(iii) Suśruta accepts the development of breasts, uterus, vagina and vulva etc. during adolescence due to gradual accumulation of *raja*, here *raja* refers to hormones specially estrogen.

(iv) Suśruta has enumerated amenorrhoea, oligomenorrhoea and pain in vagina etc. symptoms due to decrease of *ārtava*. Cakrapāṇi has explained that these symptoms are caused by *vāyū* aggravated due to decrease of *ārtava* responsible for proper nourishment of reproductive system. This reference also indicates that probably *ārtava* refers to estrogen.

(v) Suśruta and Vāgbhata, while describing the formation of placenta write that due to obstruction to orifices of *ārtavavāhika strotas* by fetus the *ārtava* goes upwards, gets accumulated and forms placenta, left over *ārtava* moves further upwards and helps in the development of breast and increases black pigmentation of areola and lips etc. After conception the hormones formed from corpus luteum help in placenta and placental hormones alongwith ovarian and pituitary hormones help in development of breasts and formation of breast milk. Though excess pigmentation over face or areola is caused by melanin, yet estrogen plays important role in this process. Since the sex hormones are responsible for all these changes i.e. amenorrhoea, placenta formation, breast changes and pigmentation, thus this description can also be taken for hormones.

(vi) For gynecological disorders *ārtava* and *bija* are also causative factors, since *bija* or ovum is already included, hence, *ārtava* probably refers to hormones.

(vii) While giving indications for *basti*, Vāgbhata has included *ārtavanāśa* and *rajah-kṣaya* both. Use of both the words i.e. *ārtava* and *raja* indicates that probably one word refers to hormones; as ovum is invisible, thus, can not be considered here.

(viii) Hārīta says that infertile women have more amount of *ārtava*, because they can not secrete milk. The hypothalamus has inhibiting factor for prolactin responsible for milk secretion and releasing factors to all other anterior pituitary hormones. If hypothalamus becomes hyperactive, then prolactin will not be secreted, while secretion of more amount of other pituitary hormones may cause menorrhagia, or in other words this also refers to hormones.

(ix) Cakrapāṇi says that ailments develop due to disequilibrium of *dhatūs* i.e. *vāta* etc., *raja* etc. and '*raja*' etc., this reference may be considered for ovarian hormones responsible for certain gynecological disorders.

स्त्री शुक्र (Female śukra)

यदा नार्यानुपेयतां वृषस्यन्त्यौ कथञ्चन । मुञ्जतः शुक्रमन्योऽन्यमन्निश्चिस्तत्र जायते ॥

(सु० सं० शा० २/४७ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/५७ च १८७)

योषितोऽपि स्ववन्त्येव शुक्रं पुंसः समागमो गर्भस्य तत्र किञ्चित् करोतीति न चिन्त्यते ॥

(अ० सं० शा० १/७२ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/१८७ - 'गर्भस्य तत्र' के स्थान में 'तत्र गर्भस्य')

जब अत्यन्त कामातुर हुई स्त्रियाँ समागम करती हैं, और किसी प्रकार एक दूसरे में शुक्र का उत्सर्ग करती हैं, तब

अनस्थि गर्भ पैदा होता है। अन्यत्र भी स्त्री में शुक्र की उपस्थिति का वागंन है।^१

महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि स्त्रियाँ भी पुष्ट के साथ संगम करते समय शुक्र का क्षरण करती हैं परन्तु यह शुक्र गर्भ-स्थिति में कोई भाग नहीं लेता।

टीकाकार अरुणदत्त ने संभोग के समय स्त्री-शरीर से (रक्त) रेत्य के क्षरण की कल्पना की है एवं उसे गर्भ के लिए अनुपयोगी बताया है, जिसमें अष्टांगसंग्रह का उपर्युक्त श्लोक भी उद्धृत किया है।^२

महर्षि हारीत ने भी संभोग के समय स्त्री के द्वारा शुक्रोत्सर्ग का उल्लेख किया है।^३

इस स्त्री-शुक्र की आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कोई भी संज्ञा निश्चित करने के साथ ही शुक्र-धातु का स्त्री-शरीर-दृष्टया विचार आवश्यक प्रतीत होता है।

When two hypersexual women indulge in sexual act, they secrete *śukra* in each other, which results in fetus devoid of bones. Vāgbhāṭa I clarifies that though woman also secretes *śukra* during coitus however, that is useless for conception.

Commentator Arunadatta has accepted discharge of *retas* by women also during coitus which is useless for conception. Hārīta says that females also discharge *śukra* during coitus.

Before attempting to discuss this *śukra*, it would be advisable to reconsider *śukra-dhātu* in relation to female body.

शुक्रधातु (स्त्री-शरीर के परिप्रेक्ष्य में) (*Śukra-dhātu in relation to female body*)

शरीर सप्तधातुजनक है। अन्तिम धातु शुक्र का स्थान सर्वशरीर कहा गया है। यद्यपि इसके उद्भव की प्रतीति षोडश वर्षोपरांत होती है, पर सूक्ष्मरूप में उपस्थिति जन्मोपरांत से रहती है। यदि शुक्र के कर्णों का उसके क्षयादि के लक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए समष्टि रूप से अवलोकन किया जाय तो वे निम्नलिखित होंगे:-

(१) धातु रूप होने से शरीर के धारण एवं परवर्ती धातु के पोषण के लिए आवश्यक।

१. सु० सं० शा० २/३७; युग में पुत्र पुत्री होने के कारणों के अन्तर्गत उद्धृत।

२. अ० ह० शा० १/५ को अरुणदत्त टीका। (पृष्ठ ५२)

३. स्त्री शुक्रं विचिनीति च ॥ (हा० सं० तृ० स्या० ३१/५)

४. (अ) यथा हि पुष्पमुकुलस्यो गम्यो न शक्यमिहास्तीति वक्तुं, नैव नास्तीति चास्ति, सत्तां भावानामीष्यकिरिति ज्ञात्वा केवलं सौक्ष्म्यान्निष्यन्त्यते, स एव गम्यो विवृतप्रकेशरे कुसुमे कालान्तरेणाभिष्यक्तिं गच्छति; एवं बालानामपि वयः परिणामाच्चक्रस्य प्रादुर्भावे भवति॥ (सु० सं० सू० १४/१५)

(आ) यथा मुकुलपुष्पस्य सु(स्व)गम्यो नोपलप्स्यते। तत्पत्ते तद्विकाशान् तथा शुक्रं हि देहिनाम्॥

(च० सं० चि० २/४ का ३९)

(इ) अ० सं० शा० १/२१ एवं का० सं० शा० ५/४।

(ई) बालानां शुक्रमस्तेव किन्तु सौक्ष्म्याद् दृश्यते। पुष्पाणां मुकुले गम्यो यथा स्वस्ति नाप्यते ॥

तेषां तदेव तारण्ये पुष्टलाङ्गिकीमेति हि। कुसुमानां प्रफुल्लतां गम्यः प्रादुर्भवेद्यथा ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/१९३, १९४)

(उ) तारण्यस्य कुमारस्य वर्षमानेषु धातुः। अस्मिन्मज्जसु पूर्णेषु शुक्रं न प्रतिपद्यते ॥

अङ्गाङ्गेषु प्रवृद्धेषु प्रतिपद्यते धातुः। शुक्रं च षोडशे वर्षे सुव्यक्तं प्रतिपद्यते॥ (धे० सं० शा० २/२३)

५. रसादयस्तु शरीरधातुकतया धातुनारापोषकतया च धातु शब्देनोच्यन्ते.....। शुक्रं तु ओजोजनकत्वाद् धातुनारातिवेद्यः।

(च० सं० चि० १५/१७ को चक्र० टीका)

(२) गर्भोत्पादन के लिए आवश्यक, गर्भांगों को विकृत करने में समर्थ एवं गर्भ-लिंग निर्माण में सहायक।^३

(३) शरीर के बल-वर्ण उपचय के लिए आवश्यक एवं हर्ष तथा प्रीति कारक।^४

(४) दोषों से विकृत होने का स्वभाव एवं विकृत होने पर गर्भाधान में असमर्थता।^५

शुक्र का स्थान यद्यपि शुक्रधातुकला आश्रित सर्वशरीर है, परन्तु यह विशेष रूप से मज्जा, मुष्क एवं स्तनों में स्थित रहता है। विभिन्न आचार्यों के मत से शुक्रवाही स्रोतस् का मूल वृषण, शोफ, स्तन एवं मज्जा हैं। शुक्रधातु कला यद्यपि सर्व शरीर में व्याप्त है, पर इसका विशिष्ट स्थान बस्तिद्वार एवं मूत्रमार्ग के पार्श्व में है। संभोग के समय शुक्र पुष्ट के शरीर से व्युत्पन्न होकर योनि में प्रविष्ट हो गर्भ का निर्माण करता है।^६

शुक्र एवं शुक्र के निर्माण के अंगों का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुरुष के शुक्र एवं शुक्राणुओं का वर्णन है। यदि हर्ष एवं प्रीतिकारक कारणों का समावेश भी कर लिया जाय तो वृषण से निकलने वाले अंगरस का वर्णन है।

१. (अ) च० सं० शा० ४/५; सु० सं० शा० ५/२; अ० सं० शा० २/३

(आ) शुक्रादर्थः प्रसादनः। (च० सं० चि० १५/१६)

(इ)। अपरे पुनः शुक्रस्य सारं गर्भमेवामनन्ति॥ (अ० सं० शा० ६/६६)

(ई)। शुक्रादर्थः प्रजायते॥ (अ० ह० शा० ३/६३)

(उ)। शुक्रं शुक्रादागमस्य संभवः। (धे० सं० सू० ११/३)

२. च० सं० सू० २८/१८, शा० २/२९

३. च० सं० शा० २/२२; सु० सं० शा० ३/५; अ० सं० शा० २/५

४. (अ) शुक्रं धैर्यं च्यवनं प्रीतिं देहबलं हर्षं बीजाधश्च। (सु० सं० सू० १५/५, १६)

(आ) हर्षबलगर्भोत्पादनैः शुक्रम। (अ० सं० सू० १९/४)

(इ) भा० प्र० पूर्व० ३/१८८ (पृष्ठ ४७)

५. सु० सं० शा० २/३, ४; अ० सं० शा० १/२३ व २४

६. (अ) रस इक्षौ यथा दीप्तिं सर्पिस्तैलं तिले यथा। सर्वत्रानुगतं देहे शुक्रं संस्पृशते तथा ॥ (च० सं० चि० २/४ का ४६)

(आ) यथा पयसि सर्पिस्तु गृह्यचेक्षो रसे यथा। शरीरेषु तथा शुक्रं गुणां विद्याद् भिषवः॥ (सु० सं० शा० ४/२१)

७. तनु क्षीर इव सर्पिरशुरस इव गुडः शरीरे शुक्रधत्तं कलामाश्रित्य सर्वाङ्गव्यापितया स्थितं विशेषतश्च मज्जमुष्कस्तनेषु॥

(अ० सं० शा० १/७)

८. (अ) शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च। (च० सं० चि० ५/८)

(आ) शुक्रवेहे द्वे, तयोर्मूलं स्तनौ वृषणौ च। (सु० सं० शा० ९/२२)

(इ) शुक्रवाहिनां स्तनौ मुष्कौ मज्जा च। (अ० सं० शा० ६/२३)

९. (अ) सप्तमी शुक्रधत्तं नाम या सर्वप्रणितां सर्वशरीरव्यापिनी। (सु० सं० शा० ४/२०)

(आ) सप्तमी शुक्रधत्तं नाम इत्यङ्गुले दक्षिणे पादौ बस्तिद्वारस्य चाधो मूत्रमार्गमाश्रिता सकलशरीरव्यापिनी शुक्रं प्रकटीयति॥

(अ० सं० शा० ५/४१)

१०. (अ) शुक्रं तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्यीयते गर्भसमुद्भवः। वाक्यविभूषणपादवत्तत् षड्पयो स्तेष्वः प्रभवश्च तस्या॥

(च० सं० शा० २/४)

(आ) इत्यङ्गुले दक्षिणे पादौ बस्तिद्वारस्य चाप्यधः। मूत्रस्रोतः पथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ (सु० सं० शा० ४/२२)

विषय के प्रारम्भ में ही महर्षि वाग्भट का मत वर्णित है कि स्त्री-शुक्र शुक्र धातु नहीं हो सकता, क्योंकि इसका गर्भोत्पादन में कोई योगदान नहीं है, जब कि शुक्र का विशिष्ट कार्य गर्भोत्पादन है^१। यही मत टीकाकार चक्रपाण्दित का भी है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि शुक्र के निर्मल होने से उसके प्रसाद से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है, मल से नहीं। कुछ आचार्य शुक्र के मल से स्मश्रु की उत्पत्ति मानते हैं पर ऐसा नहीं है क्योंकि इस ग्रन्थ में यह मान्य नहीं है तथा यदि शुक्र के मल से स्मश्रु होते हैं तो स्त्रियों में भी शुक्र की उत्पत्ति के कारण स्मश्रु होने चाहिए। स्त्रियों में भी शुक्र होता है परन्तु वह गर्भ का आरम्भक नहीं होता^२। इसी साव को महर्षि सुश्रुत ने आर्तव शब्द से वर्णित किया है^३। टीकाकार अरुणदत्त ने संभोग के समय स्त्री-शरीर से (रक्त) रेतस् का क्षरण माना है, उन्होंने लिखा है कि यह साव बिना पुरुष के संभोग के भी कामातुर स्त्रियों को पुरुष की स्मृति आदि से होता है, परन्तु यह पुंशुक्र के अभाव में गर्भ उत्पन्न नहीं कर सकता^४। दो स्त्रियों के परस्पर संभोग से क्षति शुक्र द्वारा अनस्थि गर्भोत्पत्ति का सुश्रुत^५ द्वारा वर्णन भी वैज्ञानिक दृष्ट्या उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि पुरुष के सहयोग के बिना गर्भ असम्भव है। अतः इस स्त्री-शुक्र को भी शुक्र धातु मानना उचित नहीं है।

१. प्रत्यक्षशरीरम्-गर्भनाथ सेनजी विनचित
२. (अ) रसप्रसादे मधुः प्रकाशरनिमित्तजः। कृतदेहात् सती प्रातः स्तन्यमित्यभिपद्यते ॥
सर्वदेहाश्रितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ (सु० सं० चि० १०/१८, १९)
(आ) रसात् स्तन्यमित्यादि। रसात् स्तन्यं प्रसादत्वां (च० सं० चि० १५/१७ की चक्र० टीका)
३. पा० प्र० पूर्व० ३/११२
४. (अ) प्रीणनं जीवनं लेपः सैहे धारापूरो। गर्भात्सादृशं कर्माणि धातूनां क्रमसो विदः ॥ (अ० सं० सू० १/३३)
(आ) प्रीणनं। गर्भात्सादृशं धातुनां श्रेष्ठं कर्म क्रमरतस्मत् ॥ (अ० हं० सू० ११/४)
(इ) प्रीणनं। गर्भात्सादृशं धातूनां कीर्तानि हि। (पा० प्र० पूर्व० ३/३४)
५. (अ) शुक्रात् निर्मलतया प्रसाद एव गर्भो भवति, न तु मलजन्यं किञ्चित्। केचित् शुक्रमलतया श्रमश्रूणि वदन्ति; तत्र, तन्नेत्रभिधानात्। तथा शुक्रमलं यदि श्रमश्रूणि रसुस्तत्र स्त्रीणामपि सशुक्रतया श्रमश्रूणि भवेदु; त्वित्यक्षं सशुक्र एव, परं तासां शुक्रं गर्भाभिषेकं न भवतीत्यादि। (च० सं० चि० १५/१६ की चक्र० टीका)
(आ) यत् स्त्रीशुक्रस्य गर्भाभिषेकतत्वं, तद्वचनादेव तथा नारीरजसो गर्भाभिषेकत्वादेव लब्धम्। उक्तं च तत्रान्ते। “स्त्रीणां शुक्रं न गर्भाय भवेद्गर्भाय चार्तवम्। (सु० सं० सू० १४/१४ की चक्र० टीका)
६. सु० सं० शां० २/३६ व डट्ठण टीका (पृष्ठ ४५)
७. तत्रैव तरुणीनां कुसुमशराकान्तमानसानां तथाविधेन पुरुषसंयोगेन विना केवलत्वं स्मृतिसंसारदर्थोऽन्वाचितप्रवृत्तं (रक्तं) रेतसा किमिति गर्भो, न ज्ञाते? शुक्रार्तवं हि गर्भकारणं। पुरुशं हि स्त्रीरितोक्तपुरुषं गर्भकारणम्। न च तदत्रास्ति।
.....तदभावाद्गर्भस्यानुत्पत्तिः ॥ (अ० हं० शां० १५/५ की अरण्यदत्त टीका)
८. सु० सं० शां० २/४७ (पृष्ठ ४९)

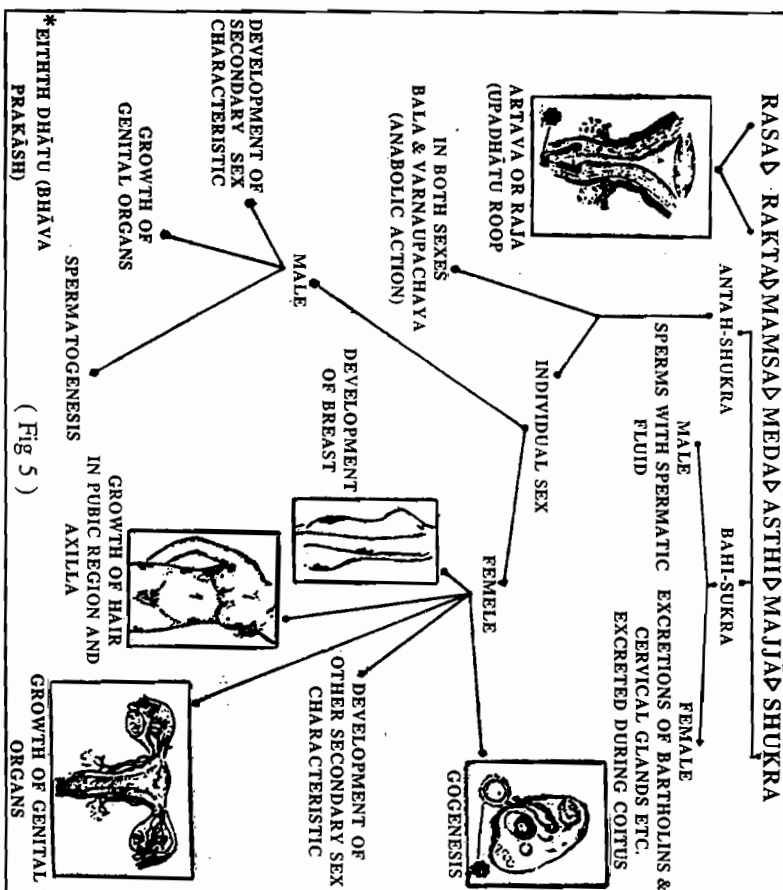
۵۳

पुरश्च शरीर में भी जननीयो के अतः एवं बहिः लावां तक ही शुक्र को सीमित करना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि शुक्र एक धातु (धारण) एवं अग्रिम धातु पोषण कृत) एवं एक प्राणायतन भी है जिसका सम्पूर्ण रूपेण विनाश होने पर जीवन असम्भव हो जायेगा, जब कि जन्मजात ही जननीयां-विरहित या व्याधि युक्त होने पर शल्य द्वारा सम्पूर्ण जननीया निकाल दिये गये हूये पुरश्च भी सामान्य आयु के होते हैं यदि 'पोषणात्' से गर्भ पोषण मानकर जननीयां-विरहित पुरश्च की सलानोत्पत्तन असमर्थता के आधार पर शुक्र धातु को जननीयां में सीमित करने का प्रयत्न किया जाय, तो भी कटिनाई होगी, क्योंकि ओज का निर्माण या पोषण शुक्र से ही होता है^१ महर्षि वाग्भट ने ओज को गर्भ का सर्वप्रथम सार, गर्भ की प्रथम धातु का प्रसाद, शुक्र का सार एवं मत भी माना है^२ यह दृश प्राणायतनों में से भी एक है^३ आचार्य भावमिश्र एवं शार्ङ्गधर ने ओज को शुक्र का उपधातु माना है^४; अतः जननीया या शुक्र की अनुपस्थिति में ओज का निर्माण न हो सकने

१. पा० प्र० पूर्व ३/१८८ (पृष्ठ ४७)
२. विकारोधाधुनैषम्यं। धातवो वातादयो रसादयश्च तथा रजः प्रपुनयश्च. तेषां वैषम्यं।
(च० सं० सू० ९४ को चक्र० टीका)
३. (अ) दशैवायतनान्याहुः। प्राणा एव प्रतिष्ठिताः शंखौ शुक्रौजसी॥ (च० सं० सू० २९/३)
(आ)। आयतनवीच आयतनानि, तदुपधाते प्राणोपधातान्, तत्राशे प्राणनाशादित्यर्थः॥ (च० सं० सू० २९/४-२ को चक्र० टीका)
(इ) दशः प्राणायातनानि; तदवशा पूर्थाओजः शुक्रं शोणितं॥ (च० सं० शा० ७/९)
(ई) दशप्राणायातनानि मूर्धा शुक्रमोजोरकम्॥ (अ० सं० शा० ५/५९)
४. (अ) शुक्रं तु ओजोनकत्वाद् धातवर्तातेनवा ओजस्तु सप्तधासुरारूपतया सप्तधावन्तारातत्वादेव।
(च० सं० वि० १५/१७ को चक्र० टीका)
(आ) ततः पुनः पच्यमानदुपमानो नोत्पद्यते सहस्रधाम्नातमुत्पद्यतु,। खेहभागाः सूक्ष्मस्तेजोभूतं ओजः।
(सु० सं० सू० १५/१० को डल्हण टीका)
(इ) तस्मात् रसादिधातुखेहपरम्पराहेतुः खेहः शुक्रम, क्षीरस्पधुतिमिवाभिन्नमोजः शुक्रेणा शुक्रवर्णनैवैजोवर्णानां निदिष्टत्वात्। (सु० सं० सू० १५/२१-२२ को डल्हण टीका)
(ई) शुक्रस्य सारमोजः। (अ० सं० शा० ६/६६)
(उ) ततः सारभूतस्य रसस्य द्वौ भागौ भवतः स्थूलः सूक्ष्मश्च। तत्र स्थूलो भागः शरीरारम्भकं शुक्रं याति सूक्ष्मः खेहभागां ओजम्। (पा० प्र० पूर्व ३/१८९)
(ऊ) तथैवैजश्च सप्तमम्। (शा० सं० पूर्व ५/१७)
(अ) यस्तस्मात् आतौ गर्भस्य यतदभ्यस्तसः॥ (अ० सं० सू० १९/३५)
(आ) शुक्रस्य सारमोजः। (अ० सं० शा० ६/६६)
(ई) ककःपितः। ओजो धातूनां क्रमणो मत्ताः॥ (अ० सं० शा० ६/७९ एवं अ० ह० शा० ३/६३, ६४)
६. च० सं० सू० २९/३; च० सं० शा० ७/९; अ० सं० शा० ५/५९
७. (अ) सत्यं राजो वसा स्वेदो दत्ताः केशास्तथैव च। ओजश्च सप्तधातूनां क्रमात् सप्तोपधातवः॥ (पा० प्र० पूर्व ३/२१२)
(आ) सत्यं रजश्च नागीनां कालो भवति गच्छति। शुद्धमूर्ताभवेः खेहः सा वसा परिकीर्तिता।
स्वेदोदत्तास्तथा केशास्तथैवैजश्च सप्तमम्। इति धातुपवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः॥ (शा० सं० पूर्व ५/१६, १७)

शुरू को धारानमकता, इसका दश प्राणायामों में से एक होता, सर्वशरीर-व्याप्ति, बल-वर्ण-उपचय तथा हृष-प्रति एवं गर्भोत्पन्ननादि कार्य तथा स्त्री एवं पुरुष में समान रूप से उपस्थिति, इन समस्त बातों को ध्यान में रखकर यदि आधुनिक विज्ञान-वर्णित-विषय से सामञ्जस्य किया जाय, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शुरु षासु से आचार्यों ने शरीर को समस्त अंतःस्वावी ग्रन्थियों विशेषतः हाइपोथैलमस एवं पोयूझाड्रि के स्रव का वर्णन किया है ।

RASAD RAKTAD MAMSA'D MEDAD ASTHID MAJJAD SHUKRA



शरीर सप्तधात्विक है, इसका निर्माण आतिसूक्ष्म कोशकों से है। यद्यपि इन धातुओं के शरीर में अपने अपने विशिष्ट स्वरूप हैं परन्तु सूक्ष्मण स्वरूप में ये प्रत्येक कोशक में विद्यमान रहती हैं। प्रत्येक कोशक विभाजित हो नए कोशक को

44

पुरुष-शरीर के वृषण को सार्व भी शुक्र के ही अन्तर्गत आते हैं किन्तु का प्रतिनिधि स्त्री-शरीर में आतव है, अतः इस आतव को भी संदर्भ भेद से शुक्र का स्त्री-शरीर-स्थित प्रतिनिधि मान सकते हैं (चित्र ५)। संभवतः इसी आधार पर महर्षि हारीत ने पुरुष एवं स्त्री दोनों के ही शरीर में रेतस् को उपास्थिति की कल्पना की है, एवं शुक्र तथा रज को रेतस् से भिन्न माना है, क्योंकि पुत्रोत्पादन में पुरुष एवं स्त्री के रेतस् तथा शुक्र एवं रज दोनों की ही अधिकता का वर्णन दिया है। टोकाकारा डल्हण ने स्थानभेद से आतव को शुक्र का परिचायक माना है।

टीकाकार अरुणदत्त ने भी स्त्री-शरीर को सप्तधात्वात्मकता का प्रश्न तो उठाया है, उसका निश्चित स्पष्टीकरण नहीं दिया, यद्यपि इन्होंने स्त्री-शरीर-स्थित रक्त में गर्भोत्पत्तिक रेतस् की कल्पना की है, परन्तु उस रेतस् का शुक्र धातु से स्पष्ट सामञ्जस्य स्थापित नहीं किया ।

Functions of *śukra* are the following ones:--

- (1) Nourishment of subsequent *dhātū* or *ojas*.
- (2) Formation of *garbha* and its sex, capable of producing teratologic abnormalities.
- (3) Betterment of complexion and strength alongwith affection and penile erection,
- (4) When vitiated by *doṣas* it can not be effective for fertilization.

With the above description śūkra may be correlated with sperms including spermatic fluid or even testosterone etc. sex hormones and same has been explained by Gaṇanātha Sena Ji as *amāh-śūkra* and *bahī-śūkra*.

१. नरेत्तोऽधिकत्वेन तथा शुक्राधिकेन तु स्त्रीततोधिकत्वेन ।
 रजसोऽधिकत्वेन (हो० सं० षष्ठस्थान १/२६, २७)
 २. अत्र आर्तवशब्दोऽयं शुक्रे वर्तते न तु रजसि। अथ यद्यभ्यर्तवशब्दः शुक्रे न वर्तते तदा अत्र शुक्रोत्पत्त्यधिकारे स्त्रीणां शुक्रस्यापुष्कलात् षड्शब्दत्वं स्यात्। तस्मात् आर्तवशब्दः शुक्रे वर्तते। (सु० सं० सू० १४/१५ की इच्छेण टीका)
 ३. स्त्रीततो-रक्तस्य उभयोरेपि च स्त्रीपुंसयोर्वयं साध्यादुक्तव्यपुष्कलत्वम्, न पुंस एव दर्शनाच्चतितप्तद्वुत् (रक्त) तेतसं पुं शुक्रं हि स्त्रीतोरक्तद्वुत् गर्भकारणम् ।
 (अ० ह० शां० १/५ की अरण्यतटीका)

Alike *śukra* in males, *stanya* (milk) is said to be present in whole female's body, but this milk is a by-product or *upadhātu* of *rasadhātu*, while *śukra* is *dhātu* and formed after *majjā*. *Strī-śukra* excreted during coitus as per Vāgbhata I can also not be considered parallel to *śukra-dhātu* as former is useless for conception, while main function of latter is conception. This very coital discharge has been termed as *ārtava* by Suśruta and *retas* by Vāgbhata II. Cakrapāṇi accepting presence of *śukra* in women, has clarified that the *garbha* is formed from essence part of pure *śukra*, not from its by-product; quoting opinion of others, writes that few erudites accept development of mousatche from by-product (waste) of *śukra* which is not accepted by Caraka, had this been the process, even women would have had the moustache due to presence of *śukra*, moreover, the *śukra* of female-body does not take part in fertilization. Achievement of boneless fetus with sexual pleasure in-between two women is also a pure hypothetical possibility never a reality; probably considering these points, Bhāvanīśra advanced the idea of eight *dhātus* in females i. e. *ārtava* as seventh and *śukra* the eighth one, but exact description regarding location, characteristics etc. is lacking there too. Hārīta has accepted presence of *retas* in both male and female in addition to *śukra* or *rajas*, predominance of this *retas* of both partners alongwith *śukra* or *rajas* and (power of) male and female respectively is said to form sex of embryo. Commentator Cakrapāṇi has also included *rajas* in the list of *dhātus* because of its capability of getting vitiated.

Even in males to limit the *śukra* in reproductive system only is not justified; because *śukra* is a *dhātu*, essential for sustenance of body and nourishment of subsequent *dhātu*. Complete absence of any specific *dhātu* will make the life impossible, moreover it is also included amongst ten *prāṇāyatanas* i.e. seats of life of the body. Individuals with complete absence of reproductive system either congenitally or due to surgical excision have a fairly normal life-span, which should not have been possible because of absence of *śukra* alongwith *ojas* which is formed or is nourished from *śukra* and is said to be its essence, byproduct or *upadhātu*.

Considering the importance of *śukra* for sustenance of life alongwith its earlier enumerated functions and presence in both sexes, it seems to be description of entire endocrine orchestra specially hypothalamic-pituitary axis. It can also be equated with prostaglandins, since these are also present in every cell and play important role in reproduction. Human body possesses seven *dhātus* and is composed of microscopic cells. Though all these *dhātus* have their specific locations in the body, however, in subtle form these are present in each and every cell. Every cell divides or reproduces itself; reproduction is function of *śukra dhātu*. It is just possible that with the advancement in the knowledge, we may come across some such substance within the cell which has specific function of cell division, then this substance would be equated with *śukradhātu*. Sperms alongwith spermatic fluid and male sex hormones are also one part of *śukra*, parallel to which females possess *ārtava* which has been clearly indicated by Dalhana (fig.5). *Strī-śukra* excreted during coitus is just secretion of bartholin's, cervical and endometrial glands coming out at the end of orgasm.

रज, शोणित, आर्तव का वर्णन (*Description of rajas, śonita or ārtava*)

(अ) रज या शोणित की बाल्यावस्था से शरीर में उपस्थिति (*Presence of rajas or śonita since childhood*)

यथा च बालस्य जीर्णस्य वा ततोः पुष्पफलं पुष्पफलस्य वा तद्विधस्य गन्धो नोपलभ्यते तथैव नोनोदशतीतसमवर्षस्य पुंसः शुक्रसेकादयः । योषितश्चोनोदशतीतपञ्चाशद्वर्षायां रजस्तन्यादय इति ॥

(अ० सं० शा० १/२१)

यथा च पुष्पमध्ये फलमनिवृत्तं सुसूक्ष्ममस्ति न चोपलभ्यते, यथा चाग्निर्दीप्त्युः सर्वगतः प्रत्यलाभावोपलभ्यते, तथा स्त्रीपुंसयोः शोणितशुक्रे कालावस्थे स्वकर्मावस्थे च भवतः ॥ (का० सं० शा० ५/४)

जिस प्रकार बालक एवं वृद्ध वृक्ष में पुष्प एवं फल की तथा नवीन (कलिका) या जीर्ण पुष्प एवं फल में गंध की प्रतीति नहीं होती, उसी भाँति १६ वर्ष से पूर्व एवं ७० वर्ष के पश्चात् पुरुषों में शुक्र-प्रसेक आदि तथा १२ वर्ष से पूर्व एवं पचास वर्ष के बाद स्त्रियों में रज (मासिक स्राव) एवं स्तन्य आदि दृष्टिगोचर नहीं होते । आचार्य भावमिश्र ने भी स्तन्य एवं आर्तव आदि की उत्पत्ति युवावस्था में मानी है ।

जिस प्रकार पुष्प के मध्य में फल अनुत्पन्न अथवा सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, काष्ठ में अग्नि सर्वत्र रहते हुए भी प्रयत्न के अभाव से उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार स्त्री एवं पुरुष में क्रमशः शोणित एवं शुक्र काल एवं कर्म की अपेक्षा रखते हैं अर्थात् अपने स्वाभाविक काल (आयु में) तथा स्वाभाविक कर्म (संयोग से शुक्र क्षरण) से प्रकट होते हैं ।

महर्षि चरक एवं सुश्रुत ने बाल्यावस्था में शरीर में शुक्र की उपस्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है (पृष्ठ ५०), पर शोणित या रज की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है । महर्षि सुश्रुत के 'रोमस्यावयवश्च विशेषा नारीणां' की टीका करते हुए टीकाकार डल्हण ने आदि शब्द से स्तन्य एवं आर्तव की उत्पत्ति वय के परिणाम (सामान्य आयु होने पर) से मानी है, टीकाकार इन्द्र ने आदि शब्द से रोम आदि ग्रहण किया है । टीकाकार चक्रपाणि ने आर्तव की बाल्यावस्था से उपस्थिति स्वीकार की है ।

As in young or aged plants flowers and fruits do not come up, as in bud and decaying flower or fruit the fragrance is not explicit, similarly in males *śukra* before sixteen and after seventy years of age and in females *raja* (menstrual blood) and *stanya* (milk) before twelve years and after fifty years of age are not visible.

As the fruit situated within the flower can not be seen being very small and the fire located within the wood can not be noticed without specific efforts, similarly *śonita* and *śukra* require appropriate time (just like fruit) and specific effort (just like fire of wood) for

१. रोमस्यावयवः पुंसं नारीणामपि यौवने जायतेऽत्र च यो भेदे ज्ञेयो व्याख्यातः स च ॥

व्याख्यानं यथा-पुंसं रोमप्राणीमश्रुपुत्रयः नारीणानु रोमप्राणीस्तन्यार्तव प्रमुपयः ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/१५५)

२. (अ) रोमस्यावयवश्च विशेषा भवा वयःपरिणामनारिणामपि प्रादुर्भवति आदिशब्दात् स्तन्यार्तवादयः ॥ (सु० सं० सू० १४/१८ की डल्हण टीका)

(आ) आदिशब्देन रोमदीनं परिग्रहः ॥ (अ० सं० शा० १/२१ की इन्द्र टीका)

३. आर्तव च यद्यपि द्विदशवर्षपूर्वम् व्यच्यते, तथाऽपि आर्तवोत्पत्तिर्भक्तल एव भवति। येन स्तनोवर्तव काले व्यक्तिर्भवति। (च० सं० शा० ४/३० की चक्र० टीका)

their gross appearance. Commentators like Dalhana and Cakrapāṇi also corroborate the view.

(आ) रज का निर्माण (Formation of *raja*)

रसात् स्रव्यं ततो (स्त्रिया-पाटीका) रक्तं। (च० सं० चि० १५/१७)।

रसादेव स्त्रिया रक्तं रजःसंज्ञं प्रवर्तते ॥ (सु० सं० सू० १४/६)

तथा रक्तमेव च स्त्रीणां मासे मासे गर्भकोष्ठमग्राप्य ऋतुं प्रवर्तमानमर्तवित्याहुः ॥ (अ० सं० शा० १/१०)

मासि मासि रजः स्त्रीणां रसज्ञं स्रवति ऋतुं ॥ (अ० ह० शा० १/१७)।

स्त्रियों में रजःसंज्ञक रक्त की प्रवृत्ति रस से होती है। वाग्भट-मतानुसार जो रक्त गर्भाशय को प्राप्त होकर प्रतिमाह तीन दिन स्रवित होता है, वह अर्तव्य कहा जाता है। रज की उत्पत्ति रस के प्रसाद भाग से होती है। अ० ह० में लिखा है कि रस धातु से उत्पन्न रज स्त्रियों में प्रत्येक मास तीन दिन तक स्रवित होता है।

उपर्युक्त आचार्यों के दृष्टिकोण में यद्यपि सामान्यतः कुछ भेद सा प्रतीत होता है क्योंकि महर्षि चरक, सुश्रुत, टीकाकार डल्हण एवं अष्टांगहृदयकार रस से ही रज (मासिक स्राव) तथा टीकाकार चक्रपाणि रस के प्रसाद भाग से ही रज संज्ञक रक्त की उत्पत्ति मानते हैं^१, जब कि अष्टाङ्गसंग्रह में गर्भाशय में एकत्रीभूत रक्त को अर्तव्य की संज्ञा दी है, यद्यपि इस संहिता में ही रस के प्रसाद भाग से रज की उत्पत्ति का भी वर्णन है^२। वास्तव में इन दोनों ही कथनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि रक्त की उत्पत्ति तो रस से ही होती है, चाहे रज या अर्तव्य रूप हो, चाहे धातु रूप। टीकाकार चक्रपाणि ने रस से रज की उत्पत्ति एवं आगे वर्णित अर्तव्य के आश्रयत्व में सामंजस्य उभरिष्यत करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि रस से उत्पन्न रज आधिर्भाव के काल में सौम्य रहता है, परन्तु तिरोभाव के काल में रक्त सदृश हो जाने से उसमें आश्रयत्व आ जाता है। इस स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि महर्षि सुश्रुत ने रक्त के आरम्भ काल के एवं वाग्भट ने विसर्जन काल के गुणों का वर्णन किया है। सौम्य अर्तव्य का आधान परिवर्तन के कारण होता है, उदाहरण स्वरूप तेज के संयोग से परिध्वं द्रव्य भी धूम सदृश हो जाते हैं, स्तेयभकारी इशुरस से उत्पन्न फणिण त्रिदोषकारी होता है, इसी प्रकार अर्तव्य में भी आश्रयत्व का आगमन हो जाता है^३।

टीकाकार अरुणदत्त ने रज को रक्त का पर्याय मानकर, रस से उत्पत्ति का स्पष्टीकरण दिया है कि यह रज रक्त के सदृश रस धातु से उत्पन्न न होकर आहार रस से ही उत्पन्न होता है^४। भावमिश्र ने रज को रक्त का उपधातु माना है एवं इसकी प्रवृत्ति मासान्तर से तीन दिन तक की कही है^५।

१. ससत् सन्ध्यामर्तवञ्च। (सु० सं० सू० १४/१० की डल्हण टीका)
२. रक्तमपी रजःसंज्ञं रसादेव प्रसादभाजनम्यम्। (च० सं० चि० १५/१७ चक्रपाणि टीका)
३. स्त्रीणां रजसोऽञ्जलवञ्चत्वाः। सन्ध्यास्य द्वौ। उभयमपि चैतद्रसप्रसादात्मकमिति॥ (अ० सं० शा० ५/१८)
४. अत्र च कमन्वशात् कालविशेषे आधिर्भावतिरोभावौ भवेयौ। अस्य धातुशोणितद्विशेषमाह,--अर्तव्यशोणितं त्वापोमिति। तु शब्दः पूर्वस्मात् सौम्योपाद्रक्तद्विशवर्तयति। अस्या च सौम्याद्रसादुत्पन्नस्याश्रयत्वं परिणामविशेषादेव कारणविसदृशं कार्यं भवति, यथा तेजसः परिध्वं धूमो भवति, इशुरासच्छ्लेष्महेतोर्विदोषकारिफणिणं भवति। अस्यैवाश्रयत्वान्वागमे हेतुमा॥ (सु० सं० सू० १४/१० की चक्रपाणि टीका)
५. रजो-रक्तं। किमर्तुं रजः? रसाज्ज्ञातं रसजम्। ननु, रक्तं स्रवयेत्।। "रसाद्रेकं ततो मांसं" इत्यादि। तत्किमर्थं स्रवयितुमर्कम्?। ससत्-आहाररसात् परिणमन्तो ज्ञातं स्रवयित्वं निर्दिष्टम्, न तु रस धातुः,॥ (अ० ह० शा० १/७ की अरुणदत्त टीका)
६. अ) रसादेव रजः स्त्रीणां मासि मासि ऋतुं स्रवते॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/२०४)

आ) भा० प्र० पूर्व० ३/२१२ (पृष्ठ ५३)

महर्षि हारीत ने स्त्रियों में रज की उत्पत्ति बिना किसी योग या प्रयत्न के ही मानी है^१।

महर्षि शार्ङ्गधर ने भी रज को रक्त की उपधातु तथा इसका प्रादुर्भाव एवं समर्पित समय पर आधारित मानी है^२। टीकाकार चक्रपाणि ने रज का वैषम्य हो व्याधि उत्पन्न की क्षमता के आधार पर इसे धातु-रूप भी माना है^३।

From *rasa* (*dhātu*), the *rakta* named *raja* is formed. *Rakta* reaching uterus and coming out for three days in every month is called *ārava*. The *raja* is formed from essence part of *rasa*.

There appears some difference of opinion regarding formation of *raja* (menstrual blood). Caraka, Suśruta, Vāgbhata II, Dalhana and Cakrapāṇi opine that it is formed from *rasa*, while Vāgbhata I says that blood accumulated in uterus, then discharged is *ārava*, the *raja* is derived from essence portion of *rasa*, actually both these descriptions are identical, because *rakta* either *dhātu-rūpa* or menstrual blood is always derived from *rasa*, thus it appears that Suśruta etc. have mentioned the earlier stage of *raja* formation while Vāgbhata I the later stage. The point has been clarified by Cakrapāṇi that during the process of formation, the *ārava* is *saumya* due to influence of *rasa*, while at the time of its excretion due to specific changes it assumes *āgreya* character. This alteration is brought due to change in character caused by *dosas* in the same way as solid substances are changed into fume due to action of fire, cane-juice a vitiating factor of *kapha* is changed after fermentation into wine which vitiates all the three *dosas*. Arunadatta opines that this *raja* is formed from *ānāvarava* and not from *rasadhātu*. Śāringadhara and Bhāwamiśra mention *raja* as by-product (*upadhātu*) of *rakta*.

विमर्श (Comments)

संहिताओं में रज / अर्तव्य की उत्पत्ति रस या रक्त से वर्णित है जो वास्तव में रज / अर्तव्य की निर्मित के दो चरणों का द्योतक है। हार्दयार्थलिंगमस, पीयूषग्रन्थि एवं दिम्बग्रन्थि के स्राव रस (प्लाज्मा) के माध्यम से ही वर्णित स्थान अर्थात् गर्भाशयान्तःकला तक पहुँचते हैं जिनसे प्रभावित गर्भाशयान्तःकला की धमनियों में रक्त का सञ्चय हो कर वह प्रतिमास स्रवित होता है, इस तथ्य को ही टीकाकार चक्रपाणि ने आधिर्भाव एवं तिरोभाव के शब्दों से वर्णित किया है। प्रारम्भ में इस रज के निर्माण के लिए सभी अंतःस्त्रावी ग्रन्थियों एवं गर्भाशय आदि के लिए पोषक रस के साथ ही, रस के माध्यम से अङ्गुरसों का वहन आवश्यक है, तत्पश्चात् अर्तव्य विमोचनी धमनी की केश सदृश सूक्ष्म शाखाओं में रक्त का एकत्रीकरण हो कर वह रक्त के रूप में प्रतिमास स्रवित होता है।

In classics *rajāārava* (menstrual blood) is said to be formed from *rasa* or *rakta*, which is actually description of two stages of its formation. The hormones of hypothalamus to pituitary then to ovary and ultimately to their target organ i.e. endometrium are carried through *rasa*, the plasma, in this endometrium the blood is accumulated and then discharged during menstruation. This very process has been explained by Cakrapāṇi with the words *ānāvarava* (formation) and *ivobhava* (discharge). Initially besides nourishment to endocrine

१. इत्यनेन च रजः स्त्रीणां विना योगेन पुत्रका॥ (श० सं० षष्ठस्थान १/१)

२. सन्ध्या रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति । ... सप्तोपधातवः॥ (शा० सं० पूर्व० ५/१६)

३. च० सं० सू० १/४ की चक्र० टीका (पृष्ठ ५३)

glands as-well-as uterus and endometrium by *rasa*, the transportation of hormones to target organs through *rasa* (plasma) is essential, then, the blood accumulated in hair thin branches of *ātravavimocini dhāmāni* (uterine artery) is discharged during menstruation.

(इ) आर्तव का आयुवत् एवं स्वरूप (*Functions and āyuvya character of ārtava*)

आर्तव शोणितं त्वाग्नेयम् ॥ (सु० सं० सू० १४/७) ।

रक्तलक्षणमातृवं गर्भकृच्च ॥ (सु० सं० सू० १५/५) ।

.... आर्तवमाग्नेयम् (सु० सं० शां० ३/३) ।

आर्तव आग्नेय, रक्त के लक्षणों वाला एवं गर्भोत्पादक है। साथ ही रक्त के कर्म अर्थात् जीवन (के लिए आवश्यक) भी है।

आग्नेयता के कारण यद्यपि आर्तव में अग्नि महाभूत की ही प्रधानता होती है परन्तु अन्य महाभूत भी सूक्ष्मरूप में उपस्थित रहते हैं। जिसका कारण उनके अणुओं का परस्पर उपकार, अनुग्रह एवं प्रवेश होता है।

Ārtava is *āgneya*, has characteristics of *rakta* (blood), forms *garbha* (fetus) and is also essential for life. Though dominant *mahābhūta* in this is *tejas*, however, others also exist in smaller amounts, the reason being assistance, acceptance, and access of their *anus* (atoms) for each other.

(ई) आर्तव का परिमाण (*Amount of ārtava*)

स्त्रीणां रजसोऽल्लयश्चत्वारः ॥ (अ० सं० शां० ५/९८)

चत्वारो रजसः स्त्रियाः ॥ (अ० ह० शां० ३/८९)

स्त्रियों के रज की सामान्य मात्रा चार अंजली होती है।

It is four *āṅgālī* (approximately four ounces).

रजोदर्शन के पूर्व बाला के शारीरिक परिवर्तन (*Changes before menarche*)

बालानामपि वयःपरिणामात् शुक्रस्य प्रादुर्भावो भवति। रोमरज्यादयश्च विशेषा नारीणाम्। (सु० सं० सू० १४/९८)

बालकों में आयु के परिणाम से शुक्र का प्रादुर्भाव होता है; उसी भाँति बालिकाओं में रोमरज्जी आदि (कक्षा एवं मग में केशोत्पत्ति) का प्रादुर्भाव होता है। टीकाकार डल्हण ने इस आदि शब्द से आर्तव एवं स्तन्य का ग्रहण किया है, एवं स्पष्ट किया है कि 'रोमरज्यादयश्च' शब्द का चकार स्त्री में भी (पुरुष के रजशु प्रभृति के समकक्ष) केशोत्पत्ति का द्योतक है। स्त्रियों में रज के उपचय होने से धीरे-धीरे स्तन, गर्भाशय एवं योनि की वृद्धि होती है।

१. रक्त लक्षणभित्तिदि।। रक्तस्य यानि लक्षणाणि तान्यस्य सम्भवतीति स्वभावकथनम्। चकारत् रक्तमाग्निं जीवनसंज्ञं करोति। (सु० सं० सू० १५/५ को डल्हण टीका)

२. सौम्यं शुक्रमर्तवमाग्नेयमितरेषामप्यत्र भूतानां सात्रियमस्त्यपुनः विशेषण, परस्सोपकारत् (परस्सरागुहात्) परस्सरानुपवेशत्वा। (सु० सं० शां० ३/३)

३. आदिशब्दात् स्तन्यातवायः, रोमरज्यादयश्चेति चकारो नारीणां चेत्यत्र द्रष्टव्यः ॥ (सु० सं० सू० १४/९८ को डल्हण टीका)

४. ... नारीणां रजसि चोपचयमाने जने; जनेः स्तनगर्भाशयोन्मिष्वुद्धिर्भवति ॥ (सु० सं० सू० १४/९५, सी० के० सेन० कलकता प्रकाशन)

महर्षि काश्यप ने यद्यपि बालावस्था में होने वाले विशिष्ट शारीरिक परिवर्तनों का कोई वर्णन नहीं किया, परन्तु बाला की योनि को होन माना है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बालिकाओं की योनि होन होने के कारण रक्त सर्वशरीर में परिभ्रमण करता है; परन्तु स्वभाववश शारीरिक परिपूर्णता प्राप्त हो जाने पर शरीर एवं योनि दोनों ही स्थलों में जाता है।

महर्षि भेल ने शारीरिक धातुओं की परिपूर्णता को रजःस्राव के प्रारम्भ का कारण माना है।

आचार्य भावमिश्र ने भी तरुणावस्था में शुक्र का प्रादुर्भाव तथा स्त्रियों में रोमरज्जी, स्तन्य तथा आर्तव की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

In boy's *śukra* (seminal ejaculate) appears after specific age, similarly in girls *romarajy* (pubic and axillary hair) grow in specific age. Dalhana includes *ārtava* (menstruation) and *stanya* (milk) also. Due to accumulation of *raja* there is gradual development of breasts, uterus and vagina alongwith vulva. The *yoni* (reproductive system) of young girls is *hina* (under developed thus menstruation does not occur), with the natural maturity specially of *dhātus* the menstruation starts.

प्रथम रजोदर्शन एवं रजोनिवृत्ति की आयु (*Age of menarche and menopause*)

तद् वर्षाद् द्वादशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् । (सु० सं० सू० १४/६)

तद् वर्षाद् द्वादशात् काले वर्तमानमसृक् पुनः ।

जरापक्राशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ (सु० सं० शां० ३/९९)

योषितश्चेन्द्रादशतीतपञ्चाशद्वर्षाया रजस्तन्यादय इति । (अ० सं० शां० १/२९)

वत्सराद् द्वादशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् । (अ० ह० शां० १/७)

स्त्रियों में १२ वर्ष की अवस्था से रजःस्राव होना प्रारम्भ होकर ५० वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है अर्थात् १२ वर्ष से पूर्व एवं ५० वर्ष के बाद यह उपस्थित नहीं रहता।

महर्षि काश्यप ने शोणित की अर्भिक्य की अवस्था शुक्र के सदृश हो १६ वर्ष मानी है; परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विशिष्ट आहार एवं आरोग्य आदि से प्रभावित हो, ये शोणित या शुक्र आयु से पूर्व भी परितक्षित हो सकते हैं; सम्भवतः यहाँ पर महर्षि काश्यप ने यह प्रथम रजोदर्शन की आयु न देकर गर्भाधान की दृष्टि से आयु की पूर्णता की अवस्था का वर्णन दिया हो, अथवा यह आयु-वैभिन्न्य व्यक्ति, देश, काल आदि अवस्थाओं के कारण भी माना जा सकता है।

आचार्य भावमिश्र ने भी सुश्रुतादि सदृश ही आयु का वर्णन दिया है।

टीकाकार अरुणदत्त ने द्वादश वर्ष की आयु प्रायिक मानी है एवं यह स्पष्ट कर दिया है कि स्त्रियों में ग्राह्य वर्ष

१. होनयोन्मस्य बालायाः कायं गच्छति शोणितम्। अथ पूर्णस्वभावायाः कायं योनिं च गच्छति ॥ (का० सं० छि० ९/१९)

२. परिपूर्णधातुशरीरस्तु यदा भवति तदा विवेकजलालोहितं मासे मासे प्रतिवेद्यन्ति ॥ (५० सं० शां० ५/६)

३. पा० प्र० पूर्व० ३/९९३ से १९५ (पृष्ठ ५० एवं ५७)

४. गोडशब्दयोहि शोणितशुक्रयोर्भेदे प्रभवतः; अर्वागपि यदाहावविशेषादसरोप्याच्च पूर्णे भवत इति परिश्रुत ॥ (का० सं० शां० ५/४)

५. द्वादशादूर्ध्वमपञ्चाशत्समाः क्षयः ॥

तद्वर्षाद् द्वादशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/९ एवं २०४)

की भी अवस्था में रजःस्राव प्रारम्भ हो सकता है। इसी भाँति पचास वर्ष की अवस्था में क्षय भी प्रायिक है अर्थात् थोड़ा अगो-मोछे भी हो सकता है।

Twelve and fifty years is the age of menarche and menopause respectively. Kāśyapa mentioned the age as sixteen years which is probably the description of appropriate age for conception. He further says that this age can be influenced by specific *āhāra* (dietetics), and *ārogya* (health). Arunadatta opines that these are probable ages. There may be slight variation in individual cases as menarche may come at eleven years similarly age of menopause may also be delayed.

ऋतुचक्र (Menstrual cycle)

सामान्य स्त्री-शरीर में ऋतुचक्र एक मास (चन्द्रमास-२८ दिन) का वर्णित है, विभिन्न शारीरिक परिवर्तन दृष्ट्या आचार्यों ने इसे स्पष्ट तीन भागों में विभक्त किया है।

१. रजःस्राव काल-३ या ५ दिन
२. ऋतुकाल-१२ या १६ दिन

३. ऋतु व्यतीत काल-ऋतुकाल एवं रजःस्राव काल के बीच का समय जो सामान्यतः २८ दिन के ऋतुचक्र में ९ या १३ दिन का होता है (रजःस्राव ३ दिन + १२ या १६ दिन ऋतुकाल=१५ या १९ दिन, २८-१५ या १९=९ या ९ दिन)। तीनों अवस्थाओं का विवेचन अग्रिम पृष्ठों में किया जाएगा।

Entire period of one month (*candramāsa*=28 days) is divided in three i.e.

- i) *Rūjāśraya* (menstruation)—3 to 5 days.
- ii) *Ritukāla* (proliferative phase including ovulation)—12 or 16 days.
- iii) *Rita vyatitkāla* (post ovulatory phase or secretory phase)—9 or 13 days.

(१) रजःस्राव (Menstruation)

(अ) रजःस्राव काल एवं अन्तराल-अवधि (Duration of menstruation and intermenstrual period)

सभी आचार्यों के मत से यह मासिक स्राव एक-एक मास के अन्तर से आता है। स्राव की अवधि महर्षि चरक मतानुसार ५ दिन एवं वाग्भट मतानुसार तीन दिन मानी गई है। यह मतभेद सम्भवतः स्त्रियों के वैयक्तिक स्वभाव के कारण है, अतः सामान्य ३ से ५ दिन की अवधि मान सकते हैं।^१

आचार्य भावमिश्र ने भी एक-एक मास के अन्तर से ही प्रकृतिः आर्तवस्राव का वर्णन दिया है जो कि ३ दिन तक रहता है। अन्यत्र शुद्ध आर्तव के लक्षणों के वर्णन में इस रजःकाल के वैभिन्य का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि

१. द्वन्द्वशक्तिः प्रायिकमेतत्, एकादशवार्षिककणमपि स्त्रीणां रक्तप्रवृत्तिदर्शनात्। पञ्चाशतः क्षयमित्यत्राद्येवमेव चिन्त्यम्॥ (अ० ह० शा० १४० की अरुणदत्त टीका)
२. (अ) मासात्... पञ्चदशानुबन्धि ...। (च० सं० वि० ३०/२५)
- (आ) मासे मासे गर्भकोष्ठमनुश्राप्य ग्रहं प्रवर्तमानम्॥ (अ० सं० शा० १/२०)
- (इ) मासि मासि रजः स्त्रीणां रसजं स्रवति ग्रहम् ॥ (अ० ह० शा० १७)
३. (अ) मासि मासि भ्रातृणां प्रकृत्यैवार्तवं स्रवति॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/१)
- (आ) पा० प्र० पूर्व० ३/२०४ (पृष्ठ ६१)

अन्त्यधिक रक्त की प्रवृत्ति होने पर तीन दिन एवं मध्यम प्रवृत्ति होने पर पाँच दिन रजःस्राव रहता है। किसी-किसी को अल्प स्राव होने पर थोड़ा-थोड़ा सोलह दिन तक रक्तस्राव होता रहता है किन्तु यदि यह शुद्ध आर्तव (शुद्ध आर्तव के लक्षणों से युक्त) है, तो इसे भी सामान्य आर्तव जानना चाहिए।

महर्षि हारीत एवं भेल^२ ने रजःस्राव काल ७ दिन तथा अन्तराल एक मास का वर्णन किया है। आधुनिक प्रत्यक्ष ज्ञानानुसार तीन से पाँच दिन का रजःस्राव-काल मानना युक्तिसंगत है।

Intermenstrual period has been given as of one month by all the writers, however, there is difference of opinion regarding duration of menstruation as three days (Vagbhata and Bhāwamīśra), five days (Cāraka) and seven days (Hārīta and Bhela). Bhāwamīśra has further said that if flow is excessive it lasts for three days; if average then for five days; however, if slight flow without any other symptom of abnormality persists even for sixteen days, it may be considered as normal.

(आ) आर्तवोत्पत्ति के लिये गर्भाशयान्तर धमनियों में आर्तव का एकत्रीकरण एवं विसर्जन (Collection of blood in vessels of uterus for excretion)

मासेनोपचितं काले धमनीभ्यां तादातवम्।

ईषतश्चैव विवर्णं च (विगन्ध-पा० धे०) वायुयौनिमुखं नयेत् ॥ (सु० सं० शा० ३/१०)।

मासेनोपचितं रक्तं धमनीभ्यामुतै पुनः। ईषतश्चैव विगन्धं च वायुयौनिमुखं नयेत्॥

(अ० सं० शा० १/४३ एवं अ० ह० शा० १/२३, २४)

रजोवहाः सिरा यस्मिन् रजः प्रविसृज्यन्तः। पुष्पभूतं हि तद्वैवात्मासि मासि प्रवर्तते।

(का० सं० वि० ९/१७)

देवीं धमनियों (आर्तव विमोचनी) के द्वारा पूरे महिने में संचरित (गर्भाशयान्तर श्लेष्मकता में एकत्रित), कुछ कृष्णवर्ण एवं विवर्ण (विशिष्ट गन्ध युक्त) आर्तव को वायु यौनिमुख की ओर (स्रवण करने के लिए) ले जाती है। आचार्य भावमिश्र ने भी यही भाव व्यक्त किए हैं।^४

महर्षि काश्यप के मतानुसार रजोवहा सिराएँ जिस रज का विसर्जन करती हैं, पुष्परूप हो वह प्रत्येक मास में प्रवर्तित होता है।

टीकाकार विश्वामित्र का मत है कि केश के सदृश सूक्ष्म बीजरक्तवहा सिराएँ गर्भाशय को सम्पूर्ण महिने बीज की उत्पत्ति (वृद्धि) के लिए पुरित करती हैं।^५

१. पञ्चशत्रुनुबन्धि = प्रपूर्यन्त्या त्रिप्राशुनुबन्धि, ततो मध्यमप्रवृत्त्या पञ्चशत्रुनुबन्धि, ततः पृं कस्याश्चिन्नेस्रवति, तदा स्तल्पप्रवृत्त्या थोडशक्तिर्मानि यावत्तदपि शुद्धमेव॥ (पा० प्र० वि० ६८/१० टीका)
२. मासे मासे ऋतुः स्त्रीणां दृष्ट्वा ऋतुमतीक्ष्वयः। रजः सप्तदिनं यावद्दुष्टं भिषजं वर ॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १८)
३. स एष आसप्तशत्रु सर्वसञ्चारोभेदद्वयः॥ ५॥ मासे मासे प्रतिदेवन्ति। प्रतितावत्रेशं च तत् पुमसिनेन समगच्छत्यर्तवम्॥ ६॥ (धे० सं० शा० ५)
४. मासेनोपचितं काले धमनीभ्यस्तदातवम्। ईषतश्चैव कृष्णं वायुयौनिमुखं नयेत्॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/२०५)
५. सूक्ष्मकेशप्रतीकाशा बीजरक्तवहाः सिराः। गर्भाशयं तपयन्ति (पूरयन्ति-पा० धे०) मासाद्विजाय कल्पन्ते॥ (विश्वामित्र, सु० सं० सू० १४/१४ की चक्र० टीका से उद्धृत)

The blood collected for whole month by both the *dhanamās* (uterine vessels and their endometrial capillaries) assuming slight black colour and specific odour is brought downwards to vaginal orifice by *vāyā* for excretion. Viśvāmitra has clarified that hair thin vessels fill the uterus for whole month to receive *bija* (both *strī* and *punbija* or *zygote*).

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन यह स्पष्ट कर देते हैं कि रजःस्राव-काल में आने वाला रक्त गर्भाशय के अन्दर पूरे माह में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम होता है, जो आयुर्जनिक ग्रन्थों में वर्णित गर्भाशय की स्लेष्मलकला में होने वाले चक्रिक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है।

Above description clearly indicates that menstruation is a result of changes going on in vascular apparatus of uterus for whole month, or in other words this refers to cyclic changes of endometrium.

(इ) शुद्ध अर्तव का स्वरूप (Character of normal menstruation)

मासाश्लिच्छदाहतिं पञ्चान्नानुबन्धि च । नैवातिबहु नात्यल्पमर्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ २२५ ॥

गुण्डाफलसवर्णं च पञ्चालककसन्निभम् । इन्द्रोपकमङ्कशमर्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ २२६ ॥

(च० सं० चि० ३०)

शशाङ्कप्रतिमं यत् तु यद्वा लाक्षारसोपमम् । तदार्तवं प्रशंसति यद् वासो न विज्जयेत् ॥

(सु० सं० शा० २/१७)

अर्तवं पुनः शशाङ्कलाक्षारसोपमं धौतं च विरज्यमानं शुद्धमाहुः ॥ (अ० सं० शा० १/२०) ।

... अर्तवं पुनः । लाक्षारसशशाङ्काभ्यां धौतं यज्ज विरज्यते ॥ (अ० ह० शा० १/४८-१९) ।

एक मास के अन्तर से आने वाला, मिश्रितला एवं दाह तथा वेदना से रहित, मौँच यदि तक रहने वाला, मात्रा में न बहुत अल्प, न बहुत अधिक, रंग में गुण्डाफल या पद्म (पुष्प) या अलक्तक अथवा इन्द्रोप के सदृश, अर्तव शुद्ध माना जाता है ।

महर्षि सुश्रुत के मत से जो वर्ण में शशक-रक्त सदृश या लाक्षा-रस सदृश हो, एवं कपड़ों को रंजित न करे वह अर्तव शुद्ध माना जाता है ।

महर्षि वाग्भट ने शब्दभेद से सुश्रुत के ही मत का समर्थन किया है। योगरत्नाकरकार, माधव एवं भावमिश्र ने भी महर्षि चक्रक एवं सुश्रुत का ही अनुगमन किया है ।

मासिक स्राव के रक्त का वर्ण उपर्युक्त संहिताओं में वर्णित अधिक रक्तवर्ण न हो किंचित् कृष्ण वर्ण का होता है । महर्षि सुश्रुत, वाग्भट एवं भावमिश्र ने अन्यत्र (पृष्ठ ६३) रंग में ईश्वरकृष्णवर्णाता स्वीकार की है । जिस वर्णाद्रिविधता का स्पष्टीकरण आचार्य भावमिश्र ने वातादि प्रकृति-भेद कहकर दिया है^३, एवं निषिच्छ होना या दाह आदि न होने का स्पष्टीकरण वायु आदि के विकार की विरहितता बताया है; अर्थात् शुद्ध अर्तव आने पर किसी भी भाँति की अतिमिश्रितता तथा दाह, शूल आदि नहीं होने चाहिए ।

१. मासत् शुद्धमादिशेत् (च० सं० सदृश) शशाङ्क विज्जयेत् (सु० सं० सदृश) मा० नि० ६१६, ७; यो० र० खी० १०; भा० प्र० पूर्व० ३/२०६ (सु० सं० सदृश) ; भा० प्र० चि० ६८/१० (च० सं० के मासत् सदृश)
२. आर्तवस्य वर्णद्वयाभिधानम् वातादियुक्तिभेदेन वर्णभेदात् (भा० प्र० पूर्व० ३/२०६ टीका)
३. निषिच्छदाहतिः-अपिच्छितमदाहमशूलम्, एतेन विज्जयतादितलक्षणमिहोक्तमित्यर्थः ॥ (भा० प्र० चि० ६८/१० टीका)

The normal menstruation is that which has intermenstrual period of one month; duration of blood loss as five days (this may differ according to opinions of different authors); is not associated with pain or burning sensation, excreted blood is not unctuous, not very scanty or excessive in amount; the colour resembles the red juice of lac, red lotus flower, fruit of jequirity or rabbit's blood.

Menstrual blood is not bright red in colour as mentioned above, but is of slight blackish nature, which has been accepted by some authors at different places (page 64). Bhāwamitra has explained that this difference in colour is due to *prakṛti* (*vāyā* etc.) of individuals, and vitiated *doṣas* are responsible for symptoms like pain and burning sensation etc.

(ई) रजःस्वला-चर्या (Mode of living during menstruation)

ततः पुष्पात् प्रभृति त्रिरात्रमासीत ब्रह्मचारिण्यः शायिनी, पाणिभ्यामन्नमज्जर्याप्राद् भुञ्जाना, न च काङ्गिन्मूजामापद्येत । ततश्चतुर्थेऽहन्त्येनामुत्साह सशिरस्कं स्नापयित्वा शुक्लानि वासांस्याच्छादयेत् पुरुषं च । ततः शुक्लवाससौ सुतेवणौ सुमनसावन्त्योऽप्यभिर्कामौ संवसेयातां ॥ (च० सं० शा० ८/५५) ।

ऋतौ प्रथमदिवसात् प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवास्वप्नाग्रज्जानाश्रुतास्नानेनाभ्यङ्गनखच्छेदनप्राधानहसनकथनाति-शब्दश्रवणलेखनानित्यासात् परिहेत् ... । दर्पसंस्तरशायिनीं कतलशराववर्णाभ्यामभोजिनीं हविष्यं, ग्न्धं च भर्तुः संरक्षेत् । ततः शुद्धस्नातां चतुर्थेऽहन्त्यहत्वासः समलङ्कृतां कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनां भर्तारं दर्शयेत् ॥

(सु० सं० शा० २/२५) ।

ततः पुष्पादर्शने प्रथमदिवसात् प्रभृति ब्रह्मचारिणी स्नानाहलङ्कारहिता दर्पसंस्तरशायिनी त्रिरात्रमासीत । पणशरावकतलान्यतमे च यावक पयसा सिद्धमल्यं कर्शनादर्पशरीरात् । तीक्ष्णोष्णालसलवणानि वर्जयेत् ॥

चतुर्थेऽहन्त्युत्तिता शीतसलिलस्नानानुत्तिमाऽलङ्कृता शुक्लमात्याभ्या कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनैर्वाधिवमेव भर्तारं पश्येदनन्त्यमनाः ॥ (अ० सं० शा० १/४४-४५) ।

ततः पुष्पक्षणादेव कल्याणध्यायिनी ग्न्धम् ॥ २४ ॥

मृजालङ्कारहिता दर्पसंस्तरशायिनी । क्षैरेयं यावकं स्तोत्रं कोष्ठशोधनकर्षणम् ॥ २५ ॥

पणं शरावे हस्ते वा भुञ्जीत ब्रह्मचारिणी । चतुर्थेऽहनि ततः स्नाता शुक्लमात्याभ्या शुचिः ॥ २६ ॥

(अ० ह० शा० १/२४ से २६) ।

अथ शुद्ध स्नातां (तां) स्त्रियं (स्त्री) चतुर्थेऽहनि स्नानगृहे श्वेतेन एवाऽन्येन वाससाज्जगुण्यानवलोकयन्ती शुचिर्देवगृहं प्रविश्योद्वेष्टाणि प्रज्वलन्तं धृताक्षेतोनाभ्यर्च्य बाह्याणमीश्वरं विष्णुं स्कन्दं च संश्लेष्याभिवाद्य, निष्क्रम्य सूर्यावच्छमसविव्रिता, न तु प्रेतपिशाचरक्षासि ॥ (का० सं० शा० ५/७) ।

रजोदर्शन के समय से लेकर तीन रात्रि (दिन एवं रात्रि) ग्राह्यचारिणी रहकर भूमि में शयन करे । हाथ में अजर्जर (विना टूटा हुआ) पात्र में अन्न रखकर भोजन करे, किसी भी प्रकार का प्रक्षालन न करे । तदुपरांत चतुर्थ दिवस उद्वन लगाकर, शिर से स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण करे, पुरुष भी श्वेतवस्त्र धारण करे । इस प्रकार श्वेतवस्त्र एवं पुष्पमाला-धारित, प्रसन्न मन एक दूसरे को चाहने वाले उन पति-पत्नियों को वैद्य सहवास की आशा दे ।

महर्षि सुश्रुत ने रजःस्वलाचर्या का विशिष्ट वर्णन दिया है । उनके मत से ऋतुलाव के प्रथम दिन से ही ब्रह्मचारिणी स्त्री दिन में सोना, अर्जन, अश्रुप्रात, स्नान, अनुलेपन (चन्दनादि सुगंधित द्रव्य-प्रयोग), अभ्यास (वैत का), नखों का काटना,

तेजी से दौड़ना, हँसना, बोलना (अधिक), अत्यधिक शब्दों का सुनना, केस-प्रसाधन करना, नाच एवं परिश्रम (अत्यधिक) का त्याग करे। द्रुमं (कुश-जाति) के बने बिस्तर पर सोने वाली, हथेली या शराव(मिट्टी का बर्तन) या पत्ते (पत्तल) पर हविष्य (वृत्त के साथ शाल्योदन अथवा क्षीर-संस्कृत यवार्ज) भोजन करने वाली स्त्री तीन दिन तक पति से पृथक् रहे। तदुपरांत चौथे दिन शुद्ध-खाला, नवीन-वस्त्र-धातिता एवं अलंकृत (आभूषणों एवं माल्यदि से) स्त्री को स्वस्तिवाचन एवं मंगलचरण के साथ पति के दर्शन करावे। टीकाकार इत्युक्त ने 'शुद्ध' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जीर्ण शोणित के चले जाने एवं नये शोणित के अवस्थित होने से स्त्री शुद्ध हो जाती है^३, तथा रजःस्त्रला को नयः प्रयोग का निषेध किया है^३।

महर्षि व्यास (अं० संग्रह, अं० हृदयकार) ने भोजन में यावक (यव से बने खाद्य) को दुग्ध के साथ थोड़ी मात्रा में ही शरीर के कर्शार्ण एवं कोष्ठ-विशोधनार्थ खाने का विशिष्ट विधान बताया है, एवं पति-दर्शन का विधान सुश्रुत सदृश ही वर्णन किया है। पुष्पिता अर्थात् रजःस्त्रला को स्वेदन का निषेध किया है^४। अथाङ्गहृदयकार ने तीन दिन तक कल्याणव्यायना या शुभचिन्तन करने वाली रहने का भी वर्णन किया है, तथा प्रथम तीन दिन अनङ्कार-प्रयोग भी निषिद्ध बताया है।

महर्षि काश्यप ने रजःस्त्रला को नय^५ एवं वर्मन^६ कर्म का निषेध किया है तथा तिग्राह है कि तत्तश्चात् (ऋतुस्त्राव के पश्चात्) चौथे दिन स्नान से शुद्ध स्त्री स्नानगृह में ही श्वेत या अन्य (शुभ्र) वस्त्रों से अपने आपको ढककर इधर-उधर न देखती हुई, पवित्र मन से देवगृह में प्रवेश कर, प्रचलित तथा हवन की हुई अग्नि की वृत्त एवं अन्न आदि से पूजा करके, ब्राह्मण, ईश्वर, विष्णु तथा स्कन्द को देखकर तथा उनका अभिवादन करके, सूर्य एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे। प्रेत, पिशाच एवं राक्षस आदि को नमस्कार न करे।

महर्षि भेल ने रजःस्त्रला के समय होने वाली रक्त को पुराण रज को संज्ञा देते हुए इस काल में संभोग का निषेध किया है^७।

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत का पूर्णरूपेण अनुगमन किया है^८।

From the day of onset of menstruation the lady should observe chastity; should avoid sleeping in day time, application of collyrium, shedding of tears, ablutio, bathing, anoint-

१. हविष्यं सपुनश्चाल्योदनादि, क्षीरसंस्कृतं यवार्जमित्येके ॥ (सु० सं० शा० २/२५ की इत्युक्त टीका)
२. शुद्धा जीर्णशोणितानामेन, अनन्तरं खाला, तदुक्ते-“नवे तनौ च सञ्जाते विपते जीर्णशोणिते। नारी भवति संशुद्धा पुंस संसृज्यते तदा” ॥ (सु० सं० शा २/२५ की इत्युक्त टीका)
३. अनन्तरं चेत्यादि चकारादावेत्युच्यते ... ॥ (सु० सं० वि० ४०/४९ की इत्युक्त टीका)
४. गर्भिणीं पुष्पितां सूतां ... ॥ (अं० सं० सू० २६/३२; अं० हं० सू० १७/२४)
५. न रजःस्त्रलायाः ... ॥ (का० सं० सि० ४/५)
६. पुष्पिण्यनुवर्तनी ... ॥ (का० सं० सि० ७/५)
७. (त्रय) इत्युक्तं पुराणलोचनं परिवर्जयेत्। किञ्च तत् पुराणम् ? यदादितस्त्राहं परित्यजेदुक्तं तत्पुराणम् ॥ (शे० सं० शा० ५/५)
८. आतंजलवत्तस्मादहंसा ब्रह्मचारिणी। शयाने दमशैव्यायां पर्यदेति पतिं न च ॥
को शरावे पर्णं वा हविष्यं ब्रह्ममाहरेत्। अशुभतं नखच्छेदमप्यङ्गमुत्तेज्यते ॥
नेत्रयोर्जनं स्नानं दिवास्नानं प्रधानम्।
अत्युच्छास्त्रद्वयं हसनं बहुभाषणम्। आयासं भूमिजननं प्रजातश्च विवर्जयेत् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३ से ५)

ing, massaging, pairing of nails, fast racing, laughing, talking (too much), listening of so many types of topics, combing and fast winds as well as excessive exercise. She should sleep on the bed made of *darbha* (specific sacred leafy plant) spread over ground. She should eat *harviya* (meal made of *ghee*, *śālī* rice and milk) or *yāvaka* (meal made of barley and milk) keeping the same directly over palm or in a utensil made of clay or leaves or unbroken utensil held in hand. She should not adorn herself with ornaments. Use of *maṣya* (inhalations), *śvedana* (sudation) and *vamana* (emesis) are contraindicated during this period. In order to get her body slightly emaciated and digestive system purified, she should take less quantity of meals. She should avoid pungent (*triṣṇa*), hot (*kaiṇ*) and salty (*lavana*) substances; always concentrate on thinking good or auspicious things. On fourth day after use of unguents, should take bath washing her head also, wear white or new garments along with garland of flowers and ornaments etc., then with the enchantation of religious or pious hymns, should first of all see her husband clad in white garments. Kāśyapa advises that the lady should cover herself inside the bath room itself and without looking all around enter the place of god with pious feelings; should worship the oblation fire with *rice* and *ghee* and after looking at *brāhmaṇas*, *gods*, *viṣṇu* and *skanda* etc. should perform obeisance to them, should not salute *preta*, *piśāca* or *rākṣasas*.

विमर्श (Comments)

आधुनिक काल में किसी भी विशिष्ट रजःस्त्रलावर्ण का निर्देश नहीं मिलता। संहिताओं में वर्णित निर्देशों को उपादेयता संदेहस्पद है, फिर भी उस काल की सामाजिक स्थिति को (व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था) इष्टिगोचर रखते हुए सम्भवतः इन निर्देशों को उपयोगिता को सिद्ध किया जा सकता है।

The utility of all these restrictions is doubtful, however, this reflects the social customs of that period, in which for earning livelihood hard work was needed, these restrictions might help in avoiding this hard labour at least for those three days when the lady is definitely physically and psychologically in some changed status. However, in to-day's changed social structure, it is not possible to observe these strictly. Consequences due to non-observance described later do not seem to be correct one.

(उ) रजस्त्रला में अञ्जनादि एवं नयस से हानि (Consequences due to non-avoidance of restricted acts)

दिवा स्वप्न्याः स्वापशीलः अञ्जनादभ्यः, रोदनम् विकृतदृष्टिः, स्नानानुलेपनाद् दुःखशीलः, तैलाप्यङ्गनात् कुष्ठे, नखापकर्तनात् कुनखी, प्रधावनाच्चञ्चलः, हसनाच्छ्वावादन्तीष्ठालुब्धः, प्रलापी चालिकश्चनात्, अतिशब्द-श्रवणाद् बधिरः, अवलेखनाद् खलितः, मारतायाससंभवमदुःमनो गर्भो भवतीत्येवमतान् परिहरेत् ॥

..... रजःस्त्रलाया ऋतुव्यापद्यते (का० सं० सि ४/६)

(सु० सं० शा० २/२५)

ऋतुस्त्राव के समय स्त्री के दिन में सोने से गर्भ निर्माल, अंजन करने से अभ्या, सोने से विकृत दृष्टि का, स्नानानुलेपन से दुःखशील (हर समय दुःखी रहने वाला), तैल के अभ्यांग से कुष्ठरोग-पीडित, नख काटने से विकृत नख वाला या कुनखी, तेजी से दौड़ने से चंचल, हँसने से श्वाव वर्ण के दाँत, ओष्ठ, तालु एवं जिह्वा वाला, बहुत बोलने से चांचाल, अतिशब्द

श्रवण से बाधित, अवलेखन से अर्थात् कंधी आदि से केश-मज्जा करने से खलित या गंगा, वायु के अतिसेवन या अतिपरिश्रम करने से उन्मत्त होता है (जिस रजःस्राव के समय यह क्रियाएं स्त्री करती है उसके तुरंत बाद होनेवाले गर्भाधान से उत्पन्न बालक में उपर्युक्त शारीरिक या मानसिक विकार पाए जाते हैं)। अतः इन क्रियाओं का परित्याग करना चाहिए।

महर्षि काश्यप का मत है कि रजःस्राव को नस्य देने से उसे ऋतुस्राव सम्यन्त्री व्यापिया हो जाती है। इन व्यापियों को पुष्पाध्याय एवं यूष्माध्याय आदि अध्यायों में वर्णित औषधियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये; विशेषकर जीवनीय द्रव्यों से साधित क्षीर का प्रयोग करना चाहिये।^१

आचार्य भावमिश्र ने सुश्रुत का ही अक्षरशः पालन करते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि निषिद्ध कर्म करने से प्रकृति दोष गर्भ में विकृति उत्पन्न करते हैं एवं अवलेखन के स्थान पर भूमिखनन का वर्णन देकर भूमिखनन से गर्भ में चलते चलते लड़खड़ाकर मिर जाने की विकृति का वर्णन दिया है।^२

If the woman does not avoid earlier described acts due to ignorance, neglect, greed or fortune, the vitiated *doṣas* reaching the fetus produce following abnormalities.

Restricted acts of woman

Abnormalities in the child

Day sleeping	Over sleepy.
Use of collyrium	Blindness.
Weeping	Abnormality of vision.
Bathing & anointing	Saddish.
Oil massage	Leprosy and other skin disorder.
Paring of nails	Deformity of nails.
Fast racing	Wanton or fickle.
Laughing	Black colour of teeth, lips and tongue.
Over talking	Garrulous.
Over hearing	Deafness.
Combing	Baldness.
Exposure to draughts and exertion	Insane.
Scrapping or digging of earth	Falls during walking.
Use of <i>nasya</i> (inhalation)	Menstrual abnormalities.

The complications arising due to use of *nasya* during menstrual period should be treated with the drugs prescribed in *pūṣpādhyāya*, *yūṣādhyāyās* etc. chapters specifically with the milk treated with *jīvānīya* group of drugs.

१. रजःस्रावः ... पुष्पाध्याय (पाध्याय) ... येनोऽप्येवमेष भेषजं विदुःस्यत् । क्षीरं वा जीवनीयोपसिद्धमिति परिश्रुत् ॥ (का० सं० ४/७)

२. आभानाद्या प्रमादाद्या लोभाद्या दैवतश्च वा । सा चेत् कुयाजिषिद्धानि गर्भो दोषांस्तदाऽऽपुनरात् ॥
एतस्या रोदनश्रमो भवेद्विकृतलोचनः । नखच्छेदेन कुनखो कुष्ठो तन्मयङ्गतो भवेत् ॥
अनुलोपातश्च स्नानाद् दुःखशीलोऽञ्जनददकः । स्वापशीलो दिवास्वापाच्छञ्जलः स्यात् प्रधावनात् ॥
अनुचक्षश्च श्रवणाद्विधिरः खलु जायते । तालुरन्तौषजिह्वसु श्यावो हसनतो भवेत् ॥
प्रलापी भूरिकनानुस्मत्तस्तु परिश्रमात् । स्वलते भूमिखननानुस्मत्तो वातसेवनात् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/६ से १०)

(ऊ) रजःस्राव के अन्त में (चतुर्थ दिवस) प्रति दर्शन या अन्य मानसिक स्थिति का परिणाम (*Effect of psychological status of woman on fourth day of menstruation upon the child*)

पूर्व पर्यवेदुत्सता यादृशं नरमङ्गना । तादृशं जनयेत् पुत्रं भर्तारं दर्शयेदतः ॥ (सु० सं० शा० २/२६)
तदा हि यादृशमेव पर्ययति चिन्तयति वा तादृशं प्रसूत इति ॥ (अ० सं० शा० १/४६)

इच्छन्ती भर्तृसदृशं पुत्रं पर्येतुरः पतिम् । (अ० ह० शा० १/२७)

शुद्धस्वप्नमात्रा हि स्त्री यं वा पर्ययति मनसा वाऽभिप्राययति तादृशाचारवपुषं प्रायेण जनयति; तस्मादेवोवाहानुगृह्णव्यायार्नः सतः पर्येतु कल्याणमनाश्च स्यात् । (का० सं० शा० ५/१७)

ऋतुत्राता (ऋतुस्राव के चतुर्थ दिन स्नानोत्तरांत) स्त्री जिस तरह के पुरुष को देखती है, उसी तरह के पुत्र को जन्म देती है, अतः सर्वप्रथम प्रति-दर्शन का निर्देश है।

महर्षि वाग्भट ने बालक पर स्त्री के चिंतन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार के पुरुष को देखेगी या सोचेगी वैसा ही प्रसव होगा।

महर्षि काश्यप के मतानुसार शुद्ध-स्वप्ना स्त्री जिसको देखेगी या जिसका ध्यान करेगी, उसी प्रकार के आचार एवं शरीर वाली स्तनान का जन्म देगी, अतः वह देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन या आचार्य का दर्शन करे, तथा कल्याण मन वाली रहे।

भावमिश्र ने पति के अतिरिक्त अन्य प्रियजन यथा पुत्र आदि के दर्शन का भी निर्देश दिया है।^१

महर्षि हारीत ने विषय का विसृत वर्णन करते हुए लिखा है कि सात धातुओं के बल से प्रकृति एवं विकृति सम होने पर, रजःस्राव के समाप्त हो जाने पर तथा ऋतुकाल के व्याप्त हो जाने पर, स्त्री को सात्विकी, राजसी तथा तामसी जिस जिस प्रकार की भावनाएँ होती हैं, उसी प्रकार के गुण वाले पुत्र को वह जन्म देती है। वह चित्त में भ्राता या पिता या जिस भी अन्य पुरुष का स्मरण करती है, उसी प्रकार के बालक को वह जन्म देती है।^२

महर्षि भेल ने ऋतुकाल में स्त्री तथा पुरुष (संभवतः यहाँ पुरुष के सम्भोग काल का तात्पर्य है) को मानसिक स्थिति से गर्भ में पड़ने वाले परिणामों का वर्णन करते हुए लिखा है, कि यदि दोनों प्रसन्न हैं तो सात्विक, व्यायस्त या चिन्तित मन होने से राजसी तथा प्रदीन मन रहने से तामसी पुत्र की उत्पत्ति होती है।^३

The child will have similar physical and psychological characteristics to whom-so-ever the lady sees, remembers or thinks, after taking her bath on fourth day of menstruation, that is why she should first of all see her husband or else the son, kith and kin, god, cow, *brāhmana*, teacher or old persons etc. The child will also have similar *sātvika*, *rājāsika* or *tāmasika* nature as that dominant in mother after menstruation. If the couple (during coitus)

१. पूर्व पर्येतु ... ततः पर्येत्यतिम् प्रियम् ॥ ११॥ (सु० सं० सदृश)
प्रियमिति । भर्तृजनस्य पुत्रादिकमपि पर्येतु ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/११)

२. सप्तधातुबलेनापि प्रकृत्या विकृतेः समे । ऋतुव्यासजःस्त्रीणां या या भवति भावना ॥ २८॥
सात्विकी राजसी वापि तामसी वापि सतम् ॥ तादृशं जनयेद्वत् गुणैर्वा तादृशैरपि ॥ २९॥
या च भावयते चित्ते भ्रातरं पितरं नरम् । येन वा तेन सदृशं सूते सा भिषयवत् ॥ ३०॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १/२८, २९, ३०)

३. ऋतौ यदा स्त्रीपुरुषौ प्रसन्नमनसौ रतः । उपेयातामथ तदा गर्भो भवति सात्विकः ॥ १७॥

ऋतौ यदा स्त्रीपुरुषौ व्यायस्तमनसौ भुशम् । उपेयातामथ तदा गर्भो भवति राजसः ॥ १८॥

ऋतौ यदा स्त्रीपुरुषौ प्रदीनमनसौ रतः । उपेयातामथ तदा गर्भो भवति तामसः ॥ १९॥ (भे० सं० शा० ३/१७, १८, १९)

is happy, the born child would be *sāṃhika*, if worried then *vyāṣṭika* and if sorrowful then *lāṃsika*.

(ए) रजःस्राव के समय संभोग का परिणाम (*Effect of coitus performed during menstruation*)

तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमस्तां भैरुगामनमनायुषं पुंसं भवति; यश्च तत्राधायते गर्भः, स प्रसवमानो विमुच्यते। द्वितीयेऽप्येवं मृतिकागृहे वा, तृतीयेऽप्येवमसम्पूर्णोऽप्युत्पद्यते भवति। चतुर्थे तु सम्पूर्णाङ्गे दीर्घायुश्च भवति। न च प्रवतमाने रक्तो बीजं प्रविष्टुं गुणकरं भवति, यथा नद्यां प्रतिस्त्रोतः क्वाविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिवर्तते नेदर्वर्षं गच्छति तद्वदेव दृष्टव्यम्। तस्मात्त्रियमवती विराजं परिहरेत्। अतः परं मासादुपेयात् ॥ (सु० सं० शा० २/३१)

... गर्भः कुक्षिस्थ एव विनाशमाप्नुयादप्यायुर्बलानोरोगविभवो वा स्याद्विकलौट्रियो वा ऋतावाधो च गन्निवरे ... (अ० सं० शा० १/५)

... पूर्वास्तितोऽजनिदितः ... (अ० ह० शा० १/२७)

रजस्वलायाश्चेत् प्रथमेऽहनि गर्भं आपद्येत तं वाताग्भंमाचक्षते विफलं वातपृथमिवोद्भ्रान्तं; द्वितीयेऽहनि चेत् संसृते च्यवते वा; तृतीयेऽहनि सृष्टिकासने प्रियते, न वा दीर्घायुर्भवति, हीनाङ्गश्च जायते।

(का० सं० शा० ५/५)

ऋतुस्राव के प्रथम दिवस में ऋतुमती के साथ संभोग पुरुषों की आयु का नाशक होता है, यदि उस दिन (के संभोग से) गर्भाधान हो भी गया तो बालक प्रसव के बाद गुत्त ही मर जाता है, द्वितीय दिवस भी ऐसा ही होता है। तीसरे दिन (गर्भाधान होने पर) बालक असम्पूर्णगर्भात् वाला एवं अल्पायु होता है। चतुर्थ दिवस का (गर्भित बालक) सम्पूर्णांग एवं दीर्घायु होता है। रक्तस्राव की स्थिति में बीजा (शुक्र) का प्रवेश गुणकारी नहीं होता। जिस प्रकार नदी के प्रवाह के विरुद्ध फेंका हुआ तैरने वाला पदार्थ धारा के विपरीत नहीं जाता, वही दृष्टांत समझना चाहिए अर्थात् रक्तस्राव के समय प्रस्थापित शुक्र गर्भाशय में ऊपर प्रवेश नहीं कर सकता। अतः नियमों को पालन करने वाली स्त्री तीन रात्रि तक (संभोग का) परित्याग करे, उसके पश्चात् सम्पूर्ण मास सेवन (संभोग का) करे।

अध्यागसंग्रहकार के मतानुसार ऋतु के प्रथम तीन दिन में गर्भाधान होने पर गर्भ या तो कुक्षि में ही मर जाता है अथवा अल्पायु, हीन-बल, अस्वाभोग्य वाला एवं विकलौट्रिय होता है। अध्यागद्वयकार ने केवल तीन दिनों के निन्दित होने का वर्णन दिया है।

महर्षि काश्यप-मतानुसार रजस्वला में स्राव के प्रथम दिन ही यदि गर्भ स्थित हो जाय तो वह वृक्षों के वात-पुष्प की तरह फलशून्य वातागर्भ होता है अर्थात् उससे सन्तानोत्पत्ति नहीं होती। दूसरे दिन गर्भाधान होने पर गर्भस्राव हो जाता है। तीसरे दिन गर्भाधान होने पर हीनांग एवं अल्पायु बालक की उत्पत्ति होती है।

महर्षि भेल ने उपर्युक्त मतों का ही प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि रजःस्राव के तीन दिन संभोग करने से गर्भाधान नहीं होता, यदि भी है तो बालक हीनायु होता है।

आचार्य भावमिश्र ने सुश्रुत के मत का समर्थन करते हुए स्त्री की अस्पृश्यता की श्रेणियों का भी वर्णन किया है कि वह स्त्री प्रथम दिन चाण्डाली सदृश, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी सदृश एवं तीसरे दिन रजकी सदृश अस्पृश्य होती है।^१

१. तस्मिन् ग्रहे गर्भोऽपक्रमेण न तिष्ठति, अवस्थितो वा सो (ना)युषि (हे) समर्थो भवति। (शे० सं० शा० ५/५)

२. प्रवहत्सलिले धितं द्रव्यं गच्छत्यधो यथा। तथा वहति रक्तं तु धितं वीर्यमधो ब्रजेत् ॥ १२॥

अयुः क्षयमवाप्नुयात् प्रथमे दिवसे स्त्रियम्। द्वितीयेऽपि दिने रत्ने रत्नोद्गुमती तथा ॥ १३॥

तत्र यथाहिलो गर्भो जायमानो न जीवति। आहिलो यस्तृतीयेऽह्नि स्वल्पायुर्विकलान्गकः ॥ १४॥

प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी। तृतीये रजकी पुंसं यथा वर्ज्या तथाङ्गना ॥ १५॥

(भा० प्र० पूर्व० ३/१२ से १४ एवं २६)

रजस्वला के साथ संभोग के निषेध एवं परिणाम का वर्णन करते हुए लिखा है कि रजस्वला-गमन से हानि विशेषकर दृष्टि, आयु एवं तेज की हानि तथा अधर्म होता है।^१

If copulation occurs on first day of menstruation, the life span of husband shortens, however, if coitus takes place with menstruating woman (on any day) then also the life of husband shortens, his eye-sight and glory (*teja*) declines, as well as this becomes the act of unrighteousness. The penetration of *bija* (sperms) during menstrual flow is not good; as a light article thrown in the flowing river against the current never reaches upwards, similarly sperms deposited during menstruation do not reach uterus, hence, for three days the lady should avoid coitus. Effects on the child impregnated during these four days of menstruation are given here under:

Menstrual day of impregnation

Effect on the child

First

No pregnancy or pseudocyesis or intrauterine death or death immediately after delivery.

Second

Either abortion or intrauterine death or death immediately after birth or within few days of delivery.

Third

Deficient or defective body-parts and short lived.

Fourth

With all body parts, normal, healthy.

विमर्श (Comments)—

आधुनिक पुस्तकों में यद्यपि रजःस्राव-काल में संभोग का कोई विशिष्ट निषेध नहीं है, पर शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-दृष्ट्या संभोग न करना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि यह एक सम्भावना हो सकती है कि इस काल में चूँकि क्षारीय प्रतिक्रिया वाले रक्त का प्रवाह हो रहा होता है, अतः योनिनालिका की नैसर्गिक उपसर्ग-प्रतिरोधात्मक अम्लीय प्रतिक्रिया का अपाव होना एवं संभोग से पृथिव जीवाणु सीधे गर्भाशयादि अंगों में प्रविष्ट हो व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेंगे।

It is difficult to explain these abnormal effects, however, it is just possible that this might have been prescribed to deter the couples from sexual act. During menstrual blood loss the normal defence mechanism i. e. acid media of vaginal canal is lost, coitus can facilitate entry of some organisms which can reach unchecked upto peritoneal cavity via uterus and fallopian tubes.

(२) ऋतुकाल (*Ritukala*)

(अ) अवधि (*Duration*)

ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति दृढतः। अदृढतवाऽप्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥ (सु० सं० शा० ३/६)

१. रजस्वलाभकामां पृथिवैरुपपद्यङ्गया ॥ ३००-३०२ ॥

रजस्वलां गतवती नारयांसंयतात्मनाः। दृष्टायुस्तेजसां हानिर्धर्मश्च ततो भवेत् ॥ ३०३॥ (भा० प्र० पूर्व० ५)

ऋतुस्तु दृष्टान्तं द्वादशरात्रं भवति । षोडशरात्रमिदमन्ये । शुद्धयोगिगर्भाश्रयान्तं वाप्य मासमपि तु केचित् । तद्वददृष्टान्तं वाप्यस्तीत्यपरे । (अ० सं० शा० १/४०)

ऋतुस्तु द्वादशरात्रिणाः । (अ० ह० शा० १/२७)

अत ऊर्ध्वमुत्तुर्द्वादशाहं ब्राह्मणानां, एकादशाहं क्षत्रियाणां, दशाहं वैश्यानां, नवरात्रमितराणाम् ॥

(का० सं० शा० ५/५)

आर्तव-दर्शन के बाद ऋतुकाल १२ दिन का होता है, अन्य आचार्यों का कथन है कि आर्तव-दर्शन न होने पर भी स्त्री ऋतुमती होती है ।

महर्षि वाग्भट ने भी महर्षि सुश्रुत-सदृश ही लिखा है कि दृष्टान्तव ऋतुकाल बारह रात्रि का होता है । अन्य आचार्य कहते हैं कि सोलह रात्रि तथा शुद्ध योगि, गर्भाण्य एवं आर्तव होने पर पूरे एक मास का भी होता है । ऋतुकाल आर्तव के अदृश्य रहने पर भी होता है, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं ।

टीकाकार डल्हण ने ऋतुकाल के १६ एवं १२ दिनों के वर्णन का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि १२ दिन की गणना में १६ दिनों में से आदि के तीन तथा योगि-सङ्कोच के कारण अन्तिम सोलहवाँ दिन नहीं गिना जाता । इसके पूर्व आर्तव की व्याख्या करते हुए टीकाकार इन्द्र ने लिखा है कि निषिक्त बीज के फल-स्वरूप उत्पन्न होने के ही कारण इसे ऋतुकाल कहते हैं । उपर्युक्त सभी विभिन्न मतों के सामंजस्य का प्रयत्न करते हुए टीकाकार इन्द्र ने लिखा है कि गर्भाधान की विशेषता के कारण ऋतुकाल-वर्णन एक उपदर्शन मात्र है, क्रमशः उपचय एवं अपचय होने के कारण सदैव ही ऋतु होकर गर्भाधान नहीं होता ।

महर्षि कारभण ने ब्राह्मणों के लिए १२ दिन, क्षत्राणों के लिए ११ दिन, वैश्य के लिए १० दिन एवं अन्यो के लिए ९ रात्रि का ऋतुकाल माना है ।

आचार्य भावमिश्र ने १२ एवं १६ दिन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आर्तवसाव के दिन से ऋतुकाल १६ दिन का एवं गर्भ के ग्रहण योग्य काल होता है एवं इन्होंने भी महर्षि कारभण-सदृश ब्राह्मणों क्षत्रिया, वैश्य एवं शूद्रा के लिए क्रमशः १२, १०, ८ एवं ६ दिन का ऋतुकाल माना है ।

It is of twelve days, according to other opinions it may be of sixteen days; if *yoni*, *garbhāśaya* and *āraṇya* are healthy, it may be of entire month, sometimes *ṛitukāla* may come up without menstruation. Dalhāṇa has explained that in twelve days duration, the first three days and last one day of conception of *yoni* out of sixteen days duration are not counted. Since the seeds (sperms) deposited during this period are likely to bear fruit (conception), hence it is termed as *ṛitukāla*. Its duration as twelve days for *brāhmaṇas*, eleven

१. द्वादशरात्रिमिति षोडशरात्रेण मध्ये आहं दिनत्रयमन्तिमं च षोडशं योगिसङ्कोचदिनं न गणनीयम् ॥

(सु० सं० शा० ३/६ की डल्हण० टीका)

२. ऋतुश्च निषिक्तस्य बीजस्य फलप्रसवनायुगः कालः । (अ० सं० शा० १/४० की इन्द्र टीका)

३. अत्र सर्ववर्तुः क्रमोचयपचये तु विशेषः । ऋतुत्वोत्पत्तिरहितमन्ये ऋतुमिच्छन्ति ॥

(अ० सं० शा० १/४० की इन्द्र टीका)

४. (अ) आर्तवसावदिवसादुत्तुः षोडश रात्रयः । गर्भाग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः ॥

सर्वासोमेव चतुर्वर्णस्त्रीणां सर्ववादिसमताः पूर्वोक्तः समयः । ग्रन्थान्तरे तु विशेषः । तद्यथा-स्नानदिवसादूर्ध्वं द्वादशरात्रावधि ब्राह्मण्याः, दशरात्रावधि क्षत्रियाणाः, अष्टरात्रावधि वैश्याणाः, षड्वारात्रावधि शूद्राणां गर्भाश्रयणे शक्तिः । (पा० प्र० पूर्व० ३/२) (आ) ऋतुः-स्त्रीणां रजोदर्शनात् षोडशरात्रिणाः, तत्र भवमातर्वचम् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/२०६)

ऋतुचक्र एवं उसका शास्त्री-क्रिया विवेचन

or ten days for *ksatriyas*, ten or eight days for *vaishyas* and nine or six days for *śūdras* has been mentioned by Kāśyapa and Bhāvanīśra respectively. This is termed as period most suitable for achievement of conception

विमर्श (Comments)

अवधि-वर्णन-दृष्ट्या अवलोकन करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि यह ऋतुकाल का वर्णन आधुनिक संहिताओं में वर्णित ऋतुचक्र की प्रथम अवस्था (प्रोलेफेरिटिव फेज या संचयावस्था) का वर्णन है, जिस अवस्था का अन्त स्त्री के बीजोत्सर्ग से होता है; परन्तु शुद्ध योगि, गर्भाश्रयदि में पूरे मास के ऋतुकाल का वर्णन इस सामंजस्य के विरुद्ध है । ऋतुकाल का विचार आचार्यों ने गर्भोत्पत्ति के लिए सबसे उपयुक्त काल के सन्दर्भ में किया है । स्त्री-बीजोत्सर्ग सामान्य २८ दिन के ऋतुचक्र में १४ वें दिन होता है, पर ८ दिन तक कम या ज्यादा अर्थात् ७ वें से २१ वें दिन तक भी बीजोत्सर्ग देखा गया है । स्त्रीबीज की आयु उत्सर्ग के बाद १८ से २४ घण्टे तक की मानी गई है । स्त्री-शरीर में शुक्राणु प्रवेश के बाद अधिकालतः २४ से ४८ घण्टे तक ही कार्य-क्षम अवस्था में रहते हैं अर्थात् यदि संयोग ऋतुचक्र के १२ वें से १६ वें दिन तक क्रिया जाय तो गर्भोत्पत्ति की सम्भावना अधिक होती है; परन्तु विशिष्ट अवस्थाओं अर्थात् स्त्री-बीजोत्सर्ग-काल के अनुसार गर्भ-ग्रहण-काल परिवर्तित भी होता है । यह तथ्य 'बिना आर्तव-दर्शन के भी ऋतुकाल होता' इस वर्णन से और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी विशेषतया शिशु की सन्तानपातवस्था में ऐसा देखा जाता है कि किसी-किसी को रजःस्त्राव के बिना भी गर्भाधान हो जाता है । अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऋतुकाल का वर्णन प्रधानतया स्त्री-बीजोत्सर्ग-काल का वर्णन है साथ ही यह संचयावस्था को भी इंगित करता है ।

अन्य महर्षि सुश्रुत ने आहाररस से एक मास में शुक्र की निर्मित के साथ स्त्रियों में आर्तव की निर्मिति मानी है । स्त्री-बीजोत्सर्ग सामान्यतया एक मास के अन्तर से होता है । आचार्य शार्ङ्गधर ने भी एक मास में रज की उत्पत्ति का उल्लेख किया है । यह एक मास में उत्पन्न होने वाला आर्तव या रज स्त्रीबीजोत्सर्ग माना जा सकता है ।

जातिभेद से ऋतुकाल की अवधि में अन्तर का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक-दृष्ट्या कठिन है । सम्भवतः सामाजिक व्यवस्थाओं से प्रेरित हो यह वर्णन दिया गया हो ।

Apparently, it looks to be description of proliferative phase, which ends after ovulation, however, considering its existence for entire month or even without menstruation and its specific importance for conception, it seems to be description of ovulation; thus it, can be said that *ṛitukāla* denotes proliferative phase including ovulation. The description of difference in duration for different castes has no scientific relevance, it might have come up due to contemporary social structure.

In the process of formation of *dhātus* Suśrūta says that from *raja* the *śukra* and also *āraṇya* in females is formed in a month. Sārngadhara has also accepted the formation of *raja* in a month. This *raja* or *āraṇya* formed in a month may be considered as ovulation.

(आ) ऋतुकाल में ही गर्भाधान होने का कारण (The reason for conception occurring only during *ṛitukāla*)

निरतं दिवसेऽतीते सङ्कुचालम्बुजं यथा । ऋतौ व्यतीते नार्यास्तु योनिः संव्रियते तथा ॥

(सु० सं० शा० ३/१)

पदमं सङ्कोचमायाति दिनेऽतीते यथा तथा । ऋतावतीते योनिः सा शुक्रं नान्तः प्रतीच्छति ॥

(अ० सं० शा० १/४२ एवं अ० ह० शा० १/२२)

१. सु० सं० सू० १/४१४; शा० सं० पूर्व० ६/१० (पृष्ठ ४०)

जिस प्रकार दिवस का अन्त होते ही कमल-पुष्प संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार ऋतुकाल बीत जाने पर स्त्री को योनि संकुचित हो जाती है।

महर्षि वाग्भट ने भी सुश्रुत-सदृश ही वर्णन करते हुए लिखा है कि दिवसान्त में जिस प्रकार कमल संकुचित हो जाता है, ऋतुकाल बीत जाने पर योनि भी उसी प्रकार (संकुचित हो) शुक्र का अन्तःभाग (गर्भाशय) में ग्रहण नहीं करती। टीकाकार इन्द्र ने स्पष्टीकरण दिया है कि योनि बीज का ग्रहण नहीं करती अर्थात् गर्भाशय में बीज नहीं प्राप्त होता।

इसी काल को आचार्य भगविम्ब ने गर्भ-ग्रहण-योय-काल से सम्बोधित किया है^१, एवं इन्होंने भी ऋतुकाल के पश्चात् योनिस्वरण का वर्णन किया है।

महर्षि भेल ने भी ऋतुकाल में ही गर्भाधान का वर्णन किया है।^४

As lotus flower closes after sun-set, similarly after *rukāla* the *yoni* of woman gets constricted and does not accept *śukra* or permits the entry of *bija* (sperms) into its inner components i.e. uterus.

विमर्श (Comments)

ऋतुकाल का समय ऋतुचक्र के पहिले के १२ या १६ दिन का कहा गया है, उसके पश्चात् अर्थात् बीजोत्सर्ग के बाद प्रोजेक्टेयॉन हा-मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय-ग्रीवा-मुख के स्लेष्मा में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि शुक्राणु आसानी से गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर सकते, जिससे गर्भाधान की सम्भावना कम हो जाती है।^१ सम्भवतः इसी दृष्टिकोण की उपर्युक्त शब्दों से आचार्यों ने व्यक्त किया है।

After ovulation, during secretory phase due to influence of progesterone hormone cervical mucus becomes hostile to sperm penetration, probably this very phenomenon has been explained with difference of words.

(इ) ऋतुकाल के पश्चात् गर्भाधान-परिणाम (*Effect on the child conceived after rukāla*)

अतः परं तूत्तरोत्तमेवायुदीनां ह्रासः। (अ० सं० शा० १/४९)

अत ऊर्ध्वमकालजम्बुः। अकालजं हीनं दुर्बलमस्थिरमदृढमपीनमद्भ्युतं धान्यमिव भवति।

(का० सं० शा० ५/५)

उत्तरोत्तर काल में गर्भाधान होने पर आयु आदि का ह्रास होता है। ऋतुकाल के पश्चात् हुए गर्भाधान को अकालज कहते हैं, यह अपने यथोचित समय के अतिरिक्त समय में उत्पन्न धान्य की भाँति हीन गुणों वाला, दुर्बल, अस्थिर, अदृढ़, फलता एवं भंगुर होता है।

Life span of child shortens gradually with the impregnation occurring after *rukāla*. As the paddy sown after its appropriate season possesses less properties, is weak, unstable, unsteady, thin and fragile, similar is the case with the child.

१. योनिर्वीचं न ग्रहणाति, गर्भाशयं न प्रापयतीत्यर्थः॥ (अ० सं० शा० १/४९ की इन्द्र टीका)

२. भा० प्र० पूर्व० ३/२ (पृष्ठ ७२)

३. दिने व्यतीते निघतं सङ्कुचत्यम्बुं ...। (सु० सं० सदृश) ऋतौ = रजोदर्शनात् षोडशनिशाऽन्तर्गते काले। योनिप्रवशा द्वारा॥

४. ऋतौ च गर्भोऽप(व)तिष्ठेत्॥ (भे० सं० शा० ८/२)

(भा० प्र० पूर्व० ३/३८)

५. त्रिन्सर्वेत्स आर्वे गाढानिर्कालीना। (जेमकॉट पृ० ७९)

(ई) ऋतुमती स्त्री के लक्षण (*Characteristic features of ritumati woman*)

गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते शुद्धनातां त्रिष्यमव्यापन्नयोनिगतगर्भाशयायामुत्पत्तीमावक्ष्यहे॥

(च० सं० शा० ४/७)

यौनप्रसन्नवदनां प्रकितत्रातममुद्विजाम्। नरकामां प्रियकथां सस्तकुक्ष्यक्षिमुर्धजाम्॥

स्फूर्तभुजकुचश्रोणिनाभ्यूरुजघनसिक्चाम्। हर्षात्सुख्यपराञ्छाधि विद्यादुत्पत्तीमिति॥

(सु० सं० शा० ३/७, ८)

क्षामप्रसन्नवदनां स्फुरच्छ्रोणिपयोधराम्। सस्ताक्षिकुक्षिं पुंरकामां विद्यादुत्पत्तीं स्थियाम्॥

(अ० सं० शा० १/४९ एवं अ० ह० शा० १/२१)

पुराणे रज के बीत जाने पर (रजःश्राव होने से पिछले ऋतुकाल के पश्चात् संचित रक्त निकल जाने के बाद^१) नए रज के अवरोधित होने पर (नए ऋतुचक्र के प्रारम्भ हो जाने पर) शुद्ध स्नान की हुई, व्याधि-विरहित योनि एवं गर्भाशय तथा शुद्ध शोणित (श्रीबीज) वाली स्त्री को ऋतुमती कहा जाता है।

महर्षि सुश्रुत ने स्त्री की मानसिक स्थिति का ही विशिष्ट वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस स्त्री का मुख स्वस्थ एवं प्रसन्न हो, शरीर, मुख एवं दंत क्रीद युक्त हों, जो पुरुष (संभोग) तथा प्रेम कथाओं की आकांक्षिणी हो, जिसकी कुक्षि, अँखें तथा बाल शिथिल हों, भुजा, स्तन, श्रोणि, जंघा एवं नितम्ब प्रदेश में स्फुरण हो रहा हो तथा जिसमें अत्यंत हर्ष एवं उत्सुकता हो, उसे ऋतुमती जानना चाहिए।

महर्षि वाग्भट ने भी लिखा है कि क्रुश परन्तु प्रसन्न मुख, श्रोणि एवं स्तनों में स्फुरण वाली, अक्षि एवं कुक्षि में शिथिलता युक्त, पुरुषाकांक्षी स्त्री को ऋतुमती जानना चाहिए।

महर्षि हरीत ने भी सप्तसिद्धि त्रिक रजःश्राव होने के बाद शुद्ध योनि वाली स्त्री को ही ऋतुमती माना है।^१

Caraka says that after the previous *raja* (*raja* accumulated in previous *rukāla*) is gone and new one has settled (one menstrual cycle is over and another has set in), and after taking the bath, the woman possessing healthy *yoni*, *garbhāśaya* and *śonīya* (healthy reproductive system and ovum) is termed as *ritumati*.

According to Suśruta and others, she looks bright and healthy, her mouth and teeth are moist, she is anxious to hear love stories and have sexual relations, her flanks, eyes and hair are lax, she has quivering or twitching over arms, breasts, pelvis, umbilicus, thighs and hips and is happy and excited.

विमर्श (Comments)

वैदिक ऋतुकाल के वर्णन का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान-क्षमता प्रदर्शित करने से है, अतः महर्षि चाक ने ऋतुमती के लक्षणों में विशेषकर जननांगों की ही स्थितियों का वर्णन किया है, उनके मतानुसार यदि योनि या गर्भाशय में गर्भाधान-बाधक कोई विशिष्ट विकार है तो सामान्य रजःश्राव के होते हुये भी स्त्री ऋतुमती नहीं कहो जानी चाहिए। महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट-वर्णित समस्त लक्षणों की उपस्थिति का कारण सम्भवतः उस काल में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था है। रजःकाल में ३ दिन तक स्नानादि से वंचित रहकर जब स्त्री पुनः स्नान एवं शृङ्गार आदि करेगी, तो स्वाभाविक है कि कुछ ज्यादा

१. पुराण इति ऋतुकालातिक्रमसञ्चित्वे.....। (च० सं० शा० ४/७ की चक्र० टीका)

२. समरात्राद्योनिशुद्धिस्तस्मादुत्पत्ती भवेत्॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/९)

प्रसव एवं स्वस्थ दिखाने देनी, साथ ही चौक इस रजःस्राव-काल में उसे एकदम अलग रखा गया था एवं अब पुनः वह परिवार में सामान्य रूप से समिलित हो पति के साथ वार्तालाप एवं संभोग करेगी, इस विचार से स्मरण आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

Importance of *rukāla* is for conception. Caraka has emphasized on the healthy condition of reproductive system and ovulation, lest abnormalities of these hamper fertilization, others have described just psychological changes. It is mentioned earlier that woman was kept secluded for three days, after that use of bath and adornment on fourth day, permission or anxiety to have sexual relation might be responsible for above mentioned changes.

(ए) ऋतुमती को क्षार कर्म एवं नस्य निषेध, नस्य-दान के उपरव एवं चिकित्सा (Contraindications for the use of *kṣāra* and *nasya* by *ritumati*, consequences of use of *nasya* etc.)

क्षार-कर्म के वर्णन में सभी आचार्यों ने ऋतुमती को क्षार-प्रयोग (अंतः एवं बहिः या पानीय एवं प्रतिसारणीय दोनों) निषिद्ध किया है।

महर्षि कारक्य ने ऋतुमती को वमन निषिद्ध किया है।^१ यद्यपि नस्य-निषेध के वर्णन में सद्यःसिर से स्नान किए व्यक्ति को नस्य का निषेध है परन्तु परिणाम में शुद्ध-स्नाता को नस्य देने से योनि के शोषण का वर्णन है, अतः इस निषेध को ऋतुमती के लिए भी निषेध मान कर पाठ श्रेय भी दिया गया है। नस्य से उत्पन्न हुए उपद्रवों के लिए पुष्पाभ्यास एवं यूषाभ्यास आदि अभ्यासों में वर्णित चिकित्सा विशेषकर जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध के प्रयोग का निर्देश है।^२

Application of *kṣāra* (either internal or external) to a *ritumati* woman is contraindicated. *Nasya* (inhalation) is also contraindicated. If *nasya* is given to a *ritumati* woman then it causes dryness of her vagina, which should be treated with use of the drugs mentioned in *pūspābhyāsa* and *yūṣābhyāsa* chapters, however, milk treated with the *jīvānyā* group of drugs should specifically be used.

(३) ऋतुव्यतीत-काल (*Rituvyatita-kāla*)

इस काल में होने वाले विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों का कोई स्पष्ट उल्लेख संहिताओं में नहीं मिलता, केवल योनि-संवरण होना ही वर्णित है (देखें पृष्ठ ७३, ७४)। शरीर-रचना-दृष्ट्या योनि या गर्भाशय में इस काल में कोई परिवर्तन नहीं होता, परन्तु गर्भाधान की क्षमता अवश्य कम हो जाती है जिसका स्मयीकरण पूर्वपृष्ठों में दिया जा चुका है। इस स्थिति को ऋतुकाल (प्रोलिफेरेटिव स्थिति तथा बीजोत्सर्ग) के बाद की होने के कारण आधुनिक विज्ञान-दृष्ट्या मिक्रोटॉरि स्थिति के अनर्थात रख सकते हैं।

Except the closure or constriction of *yoni* described earlier, any other physical or psychological changes are not described for this stage. This stage coming after *rukāla* (proliferative phase and ovulation) is secretory phase.

१. (अ) अथ नैऋतः क्षारकृत्याः ऋतुमती ... (सु० सं० सू० ११/२८)

(आ) न दूधयोऽपि योच्यते ... ऋतुमती ... (अ० सं० सू० ३९/५ एवं अ० सू० ३०/४, ६)

२. पुष्पाभ्यर्तुमती गर्भणी ... (का० सं० सि० ७/५)

३. न सद्यः सिरःस्नातस्य (सिरः स्नातायाः-पा० शो०) ... शुद्धस्नाताया योनिरुपयुज्यते। स्नाताया पुष्पाभ्यास- (पा० ५/५) ... येषोऽभ्यासेषो भेषव विदद्व्यात्। क्षरे वा जीवनीयेनिसिद्धमिति परिहृता। (का० सं० सि० ४/७)

ऋतुचक्र की विभिन्न अवस्थाओं में दोष-प्राधान्य (*Status of dosas during phases of menstrual cycle*)

रजःकाल- रजःस्राव कयना वायु का कार्य है, क्योंकि यही सञ्चित रक्त को योनि में लाती है^१ अतः इस काल में वायु का ही प्राधान्य रहता है।

ऋतुकाल- नवीन रज या गोपित के आगमन से यह काल प्रारम्भ होता है^२ एवं गर्भाधान का योग्यतम काल है।

जैसा कि पूर्ववर्णित है, ऋतुकाल आधुनिक विज्ञान-वर्णित सञ्चयकाल एवं बीजोत्सर्ग का वर्णन है, इस काल में गोर्ण गर्भाशयातःकला का पुनर्निर्माण होता है, वह मोटी एवं घनी हो जाती है। शरीर में कहीं भी घनता लाने के लिए पृथ्वी महाभूत की आवश्यकता होती है, इस घनता के साथ अर्द्धात के लिए जल भी विद्यमान रहता है, कफ इन्हीं पृथ्वी एवं जल का मिश्रण है, अतः निश्चित है कि इस काल में कफ का प्रधान्य रहेगा। महर्षि वाग्भट ने स्पष्ट लिखा है कि जूत-क्षीरादि का प्रयोग करने वाली कफ-प्रधान स्त्रियों में आर्तव देर तक ठहरता है^३ अर्थात् गर्भ-ग्रहण योग्य रहता है।

टीकाकार चक्रपाणित ने भी सुश्रुत की टीका में स्पष्ट किया है कि आर्तव आरम्भ के काल में सौम्य होता है। मांस्य द्रव्य कफ प्रधान होते हैं अर्थात् आर्तव उत्पत्ति के काल में सौम्य रहता है; बाद में काल-चक्र या ऋतुचक्र के परिवर्तन से जब आर्तव के विसर्जन होने का उपक्रम होने लगता है या आर्तव का विसर्जन (बीजोत्सर्ग) होता है तब वह आग्नेय हो जाता है। अर्थात् या स्त्रीबीज आग्नेय होता है, जिसके साथ सौम्य शुक्र या शुक्राणुओं का संयोग होने से ही अग्निसेमीय गर्भ का निर्माण होता है।^४

ऋतुव्यतीत काल- यह काल स्त्री के बीजोत्सर्ग के बाद का काल है जिस काल में पुराण रज या शोणित गर्भाशय में स्थित रहता है^५। गर्भाशयातःकला की ग्रन्थियों में अत्यधिक कार्यक्षमता होती है। शरीर का ताप ०.८ से १.० डिग्री फे० तक बढ़ जाता है; अर्थात् गर्भाशयातःकला-ग्रन्थि-स्थित-धात्वीन (आर्तव के आग्नेय तत्त्व की वृद्धि) के कार्य के साथ ही सार्वदैहिक अग्नि भी वृद्ध की अवस्था में रहती है अर्थात् इस अवस्था में सामान्यतया पित्त का प्राधान्य रहता है।

तालिका ५ में तीनों अवस्थाओं का स्पष्टीकरण दिया गया है।

अवधि	तालिका ५		
	रजःकाल	ऋतुकाल	ऋतुव्यतीतकाल
अवधि	३-५ दिन	१२ या १६ दिन या सम्पूर्ण मास या रजःस्राव के बिना भी	९-२३ दिन

१. (अ) सु० सं० शा० ३/१०; अ० सं० शा० १/४३; अ० सू० शा० १/२३, २४ (पृष्ठ ६३)

(आ) ... अथान ... मुनरत्नतन्त्रभाष्ये च ... (च० सं० सि० २८/१०, ११)

(इ) ... अथानः ... समीरणः शकुन्तलं शुक्राभर्तव्यम्; (सु० सं० सि० १/१९)

(ई) अपानो ... विष्णुशुक्रतन्त्रगर्भनिक्रमपादि क्रियः। (अ० सं० सू० २०/४)

(ए) अपानो ... शुक्रातन्त्रशकुन्तलगर्भनिक्रमपादि क्रियः। (अ० सू० १२/९)

२. च० सं० शा० ४/७ (पृ० ७५); सु० सं० शा० २/२५ (पृ० ६५)

३. षूतक्षीरादिनित्यासु मुदित्यासु कफान्तरासु। आर्तव तिष्ठति चिरं विपरितोत्पत्तोऽन्यथा ॥ (अ० सं० शा० १/५७)

४. सु० सं० सू० १४/७ की चक्रपाणित टीका (पृष्ठ ५८)

५. च० सं० शा० ४/७ व चक्रपाणि टीका (पृष्ठ ७५); सु० सं० शा० २/२५ की डल्हण टीका (पृष्ठ ६५, ६६)

जननीय स्थिति	रजःकाल	ऋतुकाल	ऋतुव्यतीतकाल
देव प्रधान्य आधुनिक वर्णन	वात रजःस्राव	नवोन रज या शोणित का आधान, गर्भ ग्रहण का सुयोग्यतम काल, हर्ष औत्सुक्य, कामेच्छादि मानसिक परिवर्तन क्रफ संवत्सरकाल या प्रोलिफेरैटिव फेज तथा वीजोत्सर्ग	पुराण रज या शोणित उप- स्थिति, योनिस्वच्छता, गर्भ- ग्रहण अयोग्यता पित्त विसर्गकाल या सिक्रीटरी फेज

Rajabhāla—Excretion or movement of any substance from one place to other is the function of *vāyu*, hence this is dominated by *vāyu*.

Rukāla—The phase is characterized with proliferation of endometrium followed by ovulation. The reconstruction of tissue or proliferation or regeneration is done by *pitha* (solid substance) and *jala* (water or liquid substances), which are the *bhautika* components of *kapha*. Vāgbhaṭa has clarified that in woman having domination of *kapha* and using *ghrita* and milk etc. daily the *ārava* stays for longer period. It is already mentioned earlier that *ārava* in its stage of formation is *saumya* or has characteristics like *kapha*, thus this stage is dominated by *kapha*.

Ruavyatīta-kāla—After ovulation or *rukāla* the *ārava* becomes *āgneya* and increases the basal body temperature by 0.8° to 1.0° F. (thermogenic effect of progesterone hormone of secretory phase) or this stage is governed by *pitta*.

Preceding description is summarized in tabular form:

Specific stage	Duration	Condition of reproductive system	Dominant Dosa
1) Rajabhāla (menstrual phase)	3-5 or 7 days	Menstrual blood loss	<i>Vāta</i>
2) Rukāla (proliferative phase including ovulation)	12 or 16 days or whole month, even without menstruation	Establishment of <i>navina raja</i> (new cycles), optimum chances of fertilization, increased sexual desire, etc.	<i>kapha</i>
3) Ruavyatīta-kāla (secretory phase)	9-13 days	Presence of <i>purāṇa raja</i> and constriction of <i>yonī</i> , less chances of conception, raised body temperature.	<i>Pitta</i>



अध्याय ३

CHAPTER III

गर्भाधान-विधि

(METHOD OF IMPREGNATION)

विवाह एवं गर्भाधारण के योग्य आयु (Proper age for marriage and first conception)

(अ) विवाह के योग्य आयु एवं कथा (Marriageable age and gūṇ)

... पञ्चविंशतिवर्षाय योऽश्वत्थवर्षा पत्नीमावहेत् । (सु० सं० शा० १०/५३)

अथ खलु पुमानेकविंशतिवर्षः कथामनुवृत्त्याग्राह्यमसम्भारिणोऽनुकूलप्रसूतिं रूपशीललक्षणसम्पन्नानामविनष्टदन्तौष्ठकर्णनखकेशस्तनीं मृदुसरोपकृतिमकपिलाभिङ्गुलापहीनाधिकार्द्धी द्वादशवर्षदेशीयाममरमुज्जस-सिद्धलक्ष्मिपक्षिणक्षत्रात्प्रेष्यभीषणकानामानुद्धन्तीमन्यामनिन्द्यामनिन्द्येन विधिनिवृद्धेत् ॥ (अ० सं० शा० १/३)

पञ्चीस वर्ष का पुरुष सोलह वर्ष की स्त्री से विवाह करे । महर्षि वाग्भट ने विवाह-योग्य कथा के गुणों का विस्तृत वर्णन किया है, जैसे इक्कीस वर्ष का पुरुष अतुल्य एवं अभिजन गोत्र में उत्पन्न^१ (मातृ एवं पितृ दोनों ही कुल की असमानता), सञ्जारी रोग (औपसीरिक रोग) से प्रसिक्त कुल में अनुत्पन्न, रूप, शील, एवं गुण सम्पन्न, सम्पूर्ण अंगों वाली (हृथ, पैर, अंगुली आदि), दन्त, ओष्ठ, कर्ण, नख, केश एवं स्तन जिसके नष्ट न हुए हों (उत्पन्न होने के बाद किसी कारण से नष्ट न हुए हों), कोमलता, स्वस्थ प्रकृति वाली, न (आधिक) कपिल न पिणल वर्ण, न हीन न अधिक अंगों वाली, बगह बर्ष की आयु वाली; देवता (लक्ष्मी, उमा आदि), भुवर्ग (लक्ष आदि), नदी (गंगा, कावेरी आदि), पर्वत (विंध्य आदि), वृक्ष (चमेले आदि), पक्षी (कोकिला आदि), नक्षत्र (रोहिणी आदि), अन्त्य (नीच जाति-बोधक जैसे चाण्डाली आदि), प्रेय (दासी आदि बोधक जैसे शिवदासी आदि) एवं भीषण (डरावने नाम जैसे पूतना आदि) नामों को न धारण करने वाली, पाप-रहित, अनिन्द्य कथा के साथ अनिन्द्य विधि से विवाह करे ।

महर्षि भेल ने भी असमान गोत्र वाली स्त्री के ही सेवन को श्रेष्ठ माना है, एवं स्पष्ट लिखा है कि असमान गोत्र वाली ऋतुस्त्राला स्त्री का ही सेवन करना चाहिए, इससे मेधावी एवं स्वस्थ पुत्र ही उत्पन्न होता है ।

Suśrūta has prescribed the age of man as twentyfive and of girl as sixteen years.

A man of twentyone years should marry a girl of twelve years, who is born in a family not belonging to parents, not suffering from any contagious disease, who is beautiful, modest, possesses good qualities with complete body parts, whose teeth, lips, ears, hair and breasts are not destructed, who is delicate, good or healthy natured, has neither excessive tawny nor golden complexion, neither less nor more body parts; does not bear a name

१. पाठभेद में—'अनुवृत्त्याग्राह्यमभिजनानाम्' वर्णन है अर्थात् गोत्र तो असमान हो पर कुल की समानता अर्थात् बहुत ऊँचा या नीचा कुल न हो। (अ० सं० शा० १/३ इन्द्र व्याख्या की पुस्तक में पाठभेद)

२. इक्ष्वासमानगोत्रां वै ऋतुस्त्रालां स्त्रियं व्रजेत् । मेधादि(वि)नमरों सा पुत्रमेव प्रसूयेत् ॥ (भे० सं० शा० ३/१)

identical to goddesses, snakes, rivers, mountains, plants, birds, planets, denoting lowest castes and slaves or frightening names; and who is free from sins and is praiseworthy. The marriage should be performed with auspicious methods.

(आ) गर्भधारण या पूर्णविराता की आयु (The age of full maturity or appropriate age for conception)

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । समत्प्राताववीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥

(सु० सं० सू० ३५/१३)

तस्यां षोडशवर्षायां पञ्चविंशतिवर्षः पुरुषः पुत्रार्थं प्रयतेत । तदा हि तौ प्रासवीर्यौ वीर्यान्वितमपत्यं जनयतः ॥ (अ० सं० शा० १/४)

पूर्णाषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशेन सङ्गता । (अ० ह० शा० १/८, १)

वीर्यवन्तं सुतं सूते (अ० ह० शा० १/८, १)

पत्नीसं वर्ष की आयु में पुरुष एवं सोलह वर्ष की आयु में स्त्री सम्पूर्ण वीर्य को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टागसंहकार ने इस आयु में पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न का विधान बताया है, क्योंकि इस आयु में पति-पत्नी सम्पूर्ण वीर्य के हो जाने के कारण वीर्यान्वित पुत्रोत्पत्ति में समर्थ होते हैं।

अष्टागसंहकार के मत से सोलह वर्ष की स्त्री एवं बीस वर्ष का पुरुष सम्पूर्ण वीर्य के हो जाते हैं एवं वीर्यवान् पुत्र को उत्पन्न करते हैं। टीकाकार अमरदास ने इस आयु को प्राथमिक माना है, क्योंकि इस आयु के पूर्व भी सामान्य गर्भोत्पत्ति हो सकती है।

महर्षि चरक ने केवल पुरुष की संभोग-क्षम आयु का वर्णन किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सोलह वर्ष से पूर्व तथा सत्र वर्ष के उपरान्त आयु (दीर्घायु) की इच्छा रखने वाले पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असम्पूर्ण धातु वाला बालक (१६ वर्ष से पूर्व आयु का) यदि संभोग करता है तो वह थोड़े जल वाले तालाब की तरह शीघ्र शुष्क हो जाता है; जिस प्रकार शुष्क, रक्ष, जन्तुओं से खाया हुआ एवं जर्जर काष्ठ स्मृशमात्र से ही शीघ्र टुकड़े-टुकड़े हो जाता है, उसी भाँति (धनु-क्षीण) वृद्ध पुरुष स्त्री-गमन से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

महर्षि कारपय ने शुक्र-सम्प्रवर्तन की आयु १६ वर्ष ही बताई है जो उपर्युक्त चरक के वर्णन से सामञ्जस्य रखती है। इन्होंने भी विवाह या गर्भाधान के लिए किसी विशिष्ट आयु का निर्देश नहीं किया। अन्य संहिताओं में गर्भाधान-योग्य आयु २५ वर्ष लिखी है, इन दोनों ही वर्णनों में कोई वैभिन्य नहीं है। क्योंकि यद्यपि पुरुष में शुक्र का प्रारम्भ तो १६ वर्ष में ही हो जाता है, परन्तु वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार उसे पत्नीसं वर्ष तक ब्रह्मचर्य अवस्था में रखने के बाद ही गृहस्थाश्रम में आने का आदेश है, अतः गर्भाधान करने की आयु पत्नीसं वर्ष ही रखी गई है। सम्भवतः इस व्यवस्था में अष्टागसंहकार के काल में कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि इन्होंने गर्भाधान की आयु बीस वर्ष ही बताई है।

१. पूर्णानि षोडश वर्षाणि प्रायिकं चैतत्, अर्वाणि साधुगर्भदर्शनात् ॥ (अ० ह० शा० १/८ की असं० टीका)

२. ततो वै षोडशावृत्तिं सतत्याः परतो न च। आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगं कर्तुमर्हति ॥ ४० ॥

अतिबालो ह्यसंपूर्णसर्वधातुः स्त्रियं व्रज्या उपशुष्येत सहसा तदगमिव काजलम् ॥ ४१ ॥

शुक्रं रुधं यथा काष्ठं जलदराधं विजर्जरम्। स्पृष्टमायुं विशीयेत तथा वृद्धः स्त्रियो व्रजनी ॥ ४२ ॥

(च० सं० वि० २-४/४० से ४२)

३. अ) शुक्रं तु षोडशे वर्षे सम्पूर्णं सम्प्रवर्तते ॥ (का० सं० शा० ४/३६)

आ) षोडशवर्षयोर्हि शुक्रं ... ॥ (का० सं० शा० ५/४)

सुश्रुतसंहिता के पाठभेद में स्त्री की विवाह-योग्य आयु बारह वर्ष^१ एवं पूर्ण-विराता की आयु १६ वर्ष लिखी है। यदि १२ वर्ष की स्त्री से पत्नीसं वर्ष का पुरुष विवाह करेगा एवं १६ वर्ष की स्त्री में गर्भाधान करेगा तो उस समय पुरुष की आयु उन्नीस वर्ष की हो जायेगी, परन्तु दोनों ही स्थितियों में पुरुष की पत्नीसं वर्ष की हो आयु का वर्णन मिलता है, अतः यह मान सकते हैं कि सम्भवतः विवाह-योग्य बारह वर्ष की आयु का वर्णन मुरुग-वृत्ति हो अर्थात् महर्षि सुश्रुत के मतानुसार विवाह एवं गर्भधारण-योग्यता की एक ही आयु है।

Male at the age of twentyfive and female at the age sixteen are fully mature, hence, they should attempt for achievement of conception.

Since both the partners are full of valour and vigour at this age, the born child also possesses these qualities. In one edition of Suśruta Samhitā twelve and sixteen years' age of woman for marriage and full maturity respectively is given; while age of the male at both these places is mentioned as twentyfive, hence, it appears that reference of twelve years of age for marriage could be a printing mistake. In Aśāṅga Hṛdaya, the age of man is prescribed as twenty years, Arunadatta explains that this is usual age of man and woman. Caraka and Kāśyapa opine that the man is not fit for coitus before age of sixteen, after this he is capable of ejaculating semen, however, these authors have not mentioned appropriate age for impregnation.

विमर्श (Comments)

अष्टागसंहार में विवाह तथा गर्भधारण-क्षमता की पृथक्-पृथक् आयु-वर्णन का कारण सामाजिक व्यवस्था हो सकता है। इस पुरातन के रचनाकाल तक चूँकि देश में विदेशियों का आगमन हो चुका था, अतः परिवार की मर्यादा-रक्षण के विचार से बाल-विवाह प्रथा का प्रारम्भ हुआ, एवं विवाहोपरान्त बालिका मातृ-गृह में ही रहकर दिसगमन के समय से सामान्य दाम्पत्य जीवन व्यतीत करती थी, जो व्यवस्था आज भी देश के अधिकांश प्रदेशों में प्रचलित है। सभी आचार्यों ने गर्भधारण के लिए स्त्री की १६ वर्ष की आयु को ही सर्वोत्तम माना है। आधुनिक विज्ञान में भी प्रासविक दृष्टि से १६ वर्ष की आयु को ही सर्वोत्तम माना गया है।^२

The mention of marriageable age and age for conception separately by Vāgbhaṭa indicates the social pattern of that time. By the period of this book the foreign culture has established its foot firmly, the marriage of girls was ceremonialized at a very early age, lest the girls were forcibly married by the authorities. The girl was sent to her in-laws only after *gaura* (second marriage). The system is prevalent in some parts of the country even to-day.

In all the āyurvedika classics best age for conception is said to be sixteen. This observation is confirmed by Harris, who after analysing the statistics found that from a purely obsterical point of view, sixteen was the most favourable age to have a baby.

अतिबाला, अतिवृद्धा में गर्भधारण निषेध एवं परिणाम (The result of impregnation in very young or old woman)

अतिबालामतिवृद्धा वर्जयेत् । (च० सं० शा० ८/६)

१. पञ्चविंशति वर्षाय द्वादशवर्षा-यां भे०) (सु० सं० शा० १०/५८ आर्यवेदतत्त्व-संदीपिका हिन्दी व्याख्या

युक्त बौध्दभा संस्कृत सीरीज ऑफिस-बागासाही १ द्वारा प्रकाशित तृतीय संस्करण सन् १९६९ पृ० ८२) ।

२. हैरिस (१९२२) बुलि-जॉन हॉप० हॉस्पि० ३३:१२ (मुराँकर द्वारा लिखित ऑप० ऑर्गेस्टे० से उद्धृत)

ऊनषेडशवर्षायामप्रातः पञ्चविंशतिम् । यद्यधस्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विधत्ते ॥ ५४॥
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलत्रियः । तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ ५५॥

अतिवृद्धायां ... गर्भाधानं नैव कुर्वति ... ॥ ५६॥ (सु० सं० शा० १०)

ऊनषष्टिविंशतिवर्षेणोत्प्रेडशवर्षायामहितो गर्भः कुक्षिस्थ एव विनाशमानुषादत्यनुवर्तारोयविभवो
वा स्याद्विकलेन्द्रियो वा ... ॥ (अ० सं० शा० १/५)

... ... ततो न्यूनाढ्योः पुनः ।

रोमयत्यायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा ॥ (अ० ह० शा० १/९)

अतिबाला एवं अतिवृद्धा का परित्याग करना चाहिए ।

सोतह वर्ष से कम आयु वाली स्त्री में यदि पच्चीस वर्ष से कम आयु वाला पुरुष गर्भाधान करता है तो वह गर्भ
कुक्षि में ही नष्ट हो जाता है, यदि उत्तराय भी हुआ तो अधिक काल तक जीवित नहीं रहता, यदि जीवित भी रहा तो दुर्बल
इन्द्रियो वाला होता है । अतः अत्यन्त बाला में गर्भाधान नहीं करना चाहिए । अतिवृद्धा में भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए ।
वाग्भट मतानुसार इस अवस्था का गर्भ कुक्षि में ही मर जाता है अल्पायु, हीन-बल, अल्पारोग्य, अल्पविभव एवं
विकलेन्द्रिय होता है ।

आयुर्वृद्धद्वयकार ने लिखा है कि हीन (वर्ष की) आयु होने पर या तो गर्भ रहता ही नहीं या रोगी, अल्पायु तथा
अधन्य होता है ।

Very young or old woman should not be impregnated. If a woman below sixteen is
impregnated by a man of below twentyfive, either she will not conceive, or if at all con-
ceives, she will have intrauterine death of the fetus; if the child is born, it would not live
long or will have weak organs, ill health, deformed body parts etc. Aged woman also should
not be impregnated.

मैथुन के लिए अयोग्य स्त्री की अन्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएँ एवं संभोग का

परिणाम (Contraindicated conditions of woman for coitus and their effects)

तन्नात्यशिता क्षुधिता पिपासिता भीता विमनाः शोकार्ता कुब्जाऽन्यं च पुमांसमिच्छन्ती मैथुने चातिकामा वा न
गर्भं धत्ते, विगुणां वा प्रजा जनयति । अतिबालामतिवृद्धा दीर्घरोगिण्यमन्येन वा विकारेणपसुष्टां वर्जयेत् । पुरुषेऽप्येत
एव दोषाः । अतः सर्वदोषवर्जितौ स्त्रीपुरुषौ संसृज्येयताम् ॥ (च० सं० शा० ८/६)

अतिवृद्धायां दीर्घरोगियायामन्येन वा विकारेणपसुष्टायां गर्भाधानं नैव कुर्वति । पुरुषस्याप्येवविधस्य त एव दोषाः
सम्भवन्ति । (सु० सं० शा० १०/५६)

तन्नात्यशिता क्षुधिता पिपासिता भीता विमनाः शोकार्ता कुब्जाऽन्येऽप्येतदुत्पाद्यकामाऽप्यवायकामा वा न गर्भं धत्ते
विगुणं वा । तथापुरुषोऽपि । (अ० सं० शा० १/५८)

अत्यधिक भोजन की हुई, क्षुधित, डरो हुई, विना मन के, शोक युक्त, कुब्ज, अन्य पुरुष को चाहने वाली एवं अत्यधिक
कामातुर स्त्री गर्भ का धारण नहीं करती, यदि करती भी है तो विगुण एवं विकृत सन्तान को उत्पन्न करती है । अति बाला,
अति वृद्धा, दीर्घ रोग से पीड़ित (तन्त्रे काल से या जीर्ण विकारों से पीड़ित) या अन्य विकारों से आक्रान्त स्त्री का भी
परित्याग करना चाहिए । पुरुष के भी ये ही दोष हैं (अर्थात् उपर्युक्त शारीरिक या मानसिक व्याधि से आक्रान्त पुरुष को
भी मैथुन निषिद्ध है), अतः सर्वदोष-रहित स्त्री-पुरुष को ही संभोग करना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत के मत से अतिवृद्धा के अतिरिक्त दीर्घ रोगिणी या अन्य विकारों से पीड़ित स्त्री में गर्भाधान नहीं कराना
चाहिए । पुरुष में भी इसी प्रकार के दोष होते हैं । अन्यत्र पुरुष को संभोग सम्बन्धी निर्देश देते हुए तन्मय हो कर संभोग
करते, अत्यधिक मैथुन न करने, सभी ऋतुओं में तीसरे दिन तथा ग्रीष्म ऋतु में १५ वें दिन संभोग का निर्देश देते हुए
मैथुन के लिए परित्याग्य स्त्री का वर्णन किया है यथा-रजस्वला, अकामा अर्थात् मैथुन के लिए अनिच्छा वाली, मलिन,
अग्रिय, अपने से ऊँचे वर्ण की, आयु में बड़ी, व्याधि-पीड़ित, हीनाङ्गी, गर्भिणी, द्वेष रखने वाली, योनिदोष से पीड़ित,
सगोत्रा, गुरुपत्नी, सन्यासिनी तथा अगाम्या स्त्री के साथ सम्भोग नहीं करना चाहिए । सन्ध्या काल, पूर्व के दिन, गोरसर्प-
काल, अर्ध रात्रि, मध्य दिन, लज्जा अनुभव होने वाले, खुले हुए एवं अशुद्ध स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए । बलवान्
व्याक्ति को भी दूषित योनि में शुक्रोत्सर्ग नहीं करना चाहिए । उपर्युक्त सभी निषिद्ध स्थितियों के साथ अथवा स्थानों में मैथुन
करने से पुरुष को विभिन्न हानियाँ होती हैं जो प्रस्तुत पुस्तक से सम्बन्धित न होने के कारण उद्धृत नहीं हैं । गर्भिणी
के साथ सम्भोग करने से गर्भ को पीड़ा होती है ।

महर्षि वाग्भट ने महर्षि चरक का ही अनुगमन किया है एवं क्षुधिता आदि के साथ ही अति मेदुरा को भी इसी
श्रेणी में रखा है एवं अति कामातुर के स्थान में मैथुन की अनिच्छा वाली स्त्री का वर्णन किया है । अन्यत्र आधान के
काल में होने वाली व्याधि को क्लेश या मरण कारक होगा लिखा है^१ अर्थात् आधान (गर्भाधान) काल में पाति-पत्नी के
बीजों की शुद्धता के साथ दोनों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी जाँचित है ।

आचार्य भावमिश्र ने भी उपर्युक्त वर्णन सङ्गृह्य ही लिखा है कि रजस्वला, व्याधि-युक्त (असुप्त आदि) विशेषकर
योनि रोगों से पीड़ित, वय में अधिक, वर्ण में वृद्ध अर्थात् अपने से उच्च कुल में उत्पन्न, मैथुनेच्छा रहित, मलिन, गर्भिणी,
हीनाङ्गी, द्वेष करने वाली, सगोत्र, गुरुपत्नी तथा सन्यासिनी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए इससे हानि होती है ।

महर्षि भेल ने सत्व हीन, जोष (वृद्धा), व्याधि-पीड़ित, मलिन, विकृत अङ्गों वाली, विजतीय तथा दूषित कोष्ठ
(गर्भाशय) वाली स्त्रियों में संभोग का निषेध किया है, क्योंकि इस प्रकार की स्त्री-गमन से बल, आरोग्य, शरीर एवं तेज
आदि का नाश होता है, अतः ऋतुकाल में ही यथासमय स्त्री-सेवन करना चाहिए^१ ।

१. उत्तरमैथुनाहारशेषने स्यात् तन्मनाः । ११०॥ अतिस्त्रीसंयोगाच्च रक्षेदत्यन्तमात्मनः । १११॥

... स्त्रीषु संवताः । त्रिभिस्त्रिभिर्होभिर्वा समीयात् प्रमदां नरः ॥ ११३॥

सर्वेऽप्युष्टु, धर्मेयु पश्चात् पश्चाद्वद्वेष्टुः । रजस्वलाभकामां च मलिनमग्रियां तथा ॥ ११४॥

वर्णवृद्धां वयोवृद्धां तथा व्याधिं प्रगांडिताम् । हीनाङ्गीं गर्भिणीं द्वेष्यां योनिदोषसमीचिताम् ॥ ११५॥

सगोत्रां गुरुपत्नीं च तथा प्रवृजितामपि । सन्यापर्वस्यागम्यां च नोपेयात् प्रमदां नरः ॥ ११६॥

गोसर्गे चार्धरात्रे च तथा मध्यदिनेषु च । लज्जासमवहरे देशे विवृतेऽशुद्ध एव च ॥ ११७॥

दुष्टयोनौ विसर्गे तु बलवानपि वर्जयेत् ॥ ११९॥

गर्भिण्या गर्भपीडा स्याद् ... ॥ १२३॥ (सु० सं० वि० २४)

२. आधान जन्मनिधन प्रत्यगच्छ विपत्करे । नक्षत्रे व्याधिलत्तत्रः क्लेशाय मरणाय वा ॥ (अ० सं० शा० १/२१)

३. (अ) रजस्वला व्याधिमतां विशेषाद्योनिरोगिणी । वयोऽधिका च निष्कामा मलिनार्थ गर्भिणी तथा ॥

एतासां संगमरुत्सां वैगुण्यानि भवन्ति हि ॥ २६॥

व्याधिमती च वज्याः तत्र स्त्रीणां व्याधयः प्रत्यदयस्तत्तुका निषिद्धा तत्रापि विशेषाद्योनिरोगिणी ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/२६)

(आ) रजस्वलाभकामां च मलिनमग्रियां तथा ॥

वर्णवृद्धां वयोवृद्धां तथा व्याधिप्रगांडिताम् । हीनाङ्गीं गर्भिणीं द्वेष्यां योनिदोषसमीचिताम् ॥

सगोत्रां गुरुपत्नीं च तथा प्रवृजितामपि । नाभिगच्छेत् पुमान्गारौ भूतिवैगुण्यशुद्ध्या ॥ (भा० प्र० पूर्व० ५/३०० से ३०२)

४. जीर्णमसहसत्त्वां च व्याधितां मलिनं कृशम् । व्याङ्गिनीं परजन्यां च पृथिकलां कोष्ठोऽं च वर्जयेत् ।

बलमारोग्यमयुष्यं चपुस्त्येव च देहिनाम् । होयते हौदृश्यां गत्वा प्राप्याकालजलानिव ।

ऋतावृत्तौ यथाकालं मैथुनं तत्समाचरेत् ॥ (शे० सं० सू० ७/५ से ७)

The coitus should not be done with a woman having done over-eating or who is hungry, thirsty, frightened, averse, sorrow-stricken, angry, longing some one else, having absence or excessive desire for sex, fatty, chronically ill specially suffering from gynecological disorders or menorrhagia, menstruating, pregnant, emaciated or weak, dirty, unloving, elder and coming from higher caste, possessing less body-parts, jealous, belonging to one's own *gotra* (subcaste), wife of teacher and a female ascetic. These types of women either do not conceive, if conceive then the born child suffers from teratologic abnormalities. The man having gone to such woman loses his energy and health. Coitus should also not be done during twilights, festival days, early morning, mid-night, mid-day, improper place likely to cause embarrassment, open or unclean place. The man doing coitus with above contraindicated woman or place suffers from different disorders, which are not described here. The coitus done with pregnant woman troubles her fetus.

विमर्श (Comments)

संभोग के समय की पति-पत्नी की मानसिक स्थिति के प्रभाव का वर्णन अन्यत्र भी आचार्यों ने किया है कि स्त्री-पुरुष जिस प्रकार का आहार विहार एवं चेष्टाएं करते हैं उसी प्रकार के पुत्र को जन्म देते हैं। गर्भाधारण के लिए पति पत्नी में सौमनस्य होना अत्यावश्यक है। गर्भाधान के काल में स्त्री जिस प्रकार के जन्तु का ध्यान करती है, उसी प्रकार के चरित्र/आकृति-सदृश्य के गर्भ को जन्म देती है। टीकाकार डल्हण का कथन है कि विभिन्न ऋतुओं में निषिक्त गर्भ उस ऋतु के अनुसार रूप तथा आयु वाले होते हैं।^१

पन्द्रह वर्ष से कम आयु की स्त्री में गर्भाधारण होने पर न्यूनतम कैलाल की विकृतियाँ तथा तीस वर्ष के बाद उत्तरोत्तर आयु की वृद्धि में प्रथम गर्भाधारण होने पर ढाड़न सिण्ढाम होने की सम्भावना अधिक होती है। स्त्री को अनेकों व्याधियाँ यथा श्वपायस्य क्रिया हीनता, मधुमेह, उदरमर्ग यथा फिरङ्ग, रबेला, साइटोमेगालोवाइरस, टाक्सोप्लाज्मा एवं हरपिस सिम्प्लेक्स गर्भाङ्गविकृति एवं गर्भ-मृत्यु-कारक हो सकती हैं। व्याधि-विकारों के लिए प्रयुक्त विशेषकर प्रथम त्रैमास में प्रयुक्त औषधियाँ गर्भ-मृत्यु अथवा जन्मजात विकृति उत्पन्न कर सकती हैं। मानसिक अथवा/एवं शारीरिक व्याधियों से पीड़ित स्त्री में बन्ध्यात्व होने की भी सम्भावना अधिक होती है। उत्तर वर्णित निषेध इसी दृष्टिकोण से दिए गए प्रतीत होते हैं। रात्रिचर्या के अन्तर्गत ग्रीष्म एवं शरदऋतु में बाला स्त्री का सेवन तथा बाला के नित्य सेवन से बलवर्धन का वर्णन कामशास्त्र के आधार पर है, स्वास्थ्य को दृष्टि से नहीं।^३

Influence of psychological status of couple has been described at other places also i.e. what-so-ever type of diet and mode of life is used by couple, the born child has similar character. Normalcy of psychology or happiness of couple is most important for conception. During impregnation, what-so-ever animal is thought by the woman, the child takes the

१. चं० सं० सू० २५/४०; चं० सं० शा० २/२५; चं० सं० शा० ८/१४; पु० सं० शा० २/४६; अ० सं० सू० १३/३; अ० सं० शा० १५/३; अ० हं० शा० १/३१ एवं पा० १० पूर्व० ३/६२ (गर्भाधान के लिए कर्तव्य में वर्णित)
२. ऋतुवः प्रातिवर्दिदिव्य बलयोगसम्भावनाः।
तेषु गर्भा निषिकारसु तथाकालास्तथापुनः॥ (सु० सं० सू० ६/३५-३६ की डल्ह० टीका)
३. निदाशरदोर्बाला हिता विषयिणं मता । ... ॥ १८३॥
नित्यं बाला सेव्यमाना नित्यं वर्धयते बलम् । ... ॥ १८४॥ (पा० १० पूर्व ५/२८३, २८४; यो० २० रात्रिचर्या)

characters of the same. The child impregnated during specific season gets respective character or longevity.

Chances of neural canal defects in the fetus of a girl of fifteen years or less and increasing incidence of Down's syndrome in first pregnancy after thirty years onwards age of woman are noted. Certain diseases of the woman i.e. hypothyroidism, diabetes mellitus, infections such as syphilis, rubella, cytomegalovirus, toxoplasma, herpes simplex are causative factors for congenital anomalies, abortions or IUDS. Tuberculosis can cause missed abortion. Drugs used specially during first trimester can cause congenital abnormalities. Physically or mentally ill woman can become infertile. Mentioned contraindications might have been given keeping these facts in mind.

Reference of sex with *bāla* (girl before sixteen) during summer and early winter and also enhancement of vigour and potency by daily sex with *bāla* is given with the point of view of sexology not health.

सामान्य मैथुन की स्थिति एवं विभिन्न स्थितियों में मैथुन का निषेध तथा परिणाम (Normal and abnormal postures for coitus and their effect)

न च न्युब्जां पार्श्वगतं वा संसेवेत । न्युब्जाया वातो बलवान् स योनिं पीडयति, पार्श्वगताया दक्षिणे पार्श्वे रस्तेष्वा स च्युतः पित्तधति गर्भाशयं, वामे पार्श्वे पित्तं तदस्याः पीडितं विदहति रक्तं शुक्रं च, तस्मादुत्ताना बीजं गृहीयात् ; तथाहि यथास्थानमवस्थिते दोषाः । (चं० सं० शा० ८/६)

पुरुषोऽपि न चासावधिष्ठेत् । तथा हि स्त्रीचेष्टाः पुमान् जायते पुंयेष्ट वा स्त्री । ५८।

न च न्युब्जां पार्श्वगतं वा सेवेत । न्युब्जायां वातो बलवान् स योनिं पीडयति । दक्षिणपार्श्वगताया रस्तेष्वा पीडितरज्जुलोपिदधति गर्भाशयम् । वामपार्श्वगतायास्तद्विषत् विदहति रक्तशुक्रे । तस्मादुत्ताना बीजं गृहीयात् । तथाहि यथास्थानमव स्थिति दोषाः । (अ० सं० शा० १/५८, ५९)

न्युब्ज अथवा पार्श्व में लेटकर स्त्री को मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिए। न्युब्ज स्थिति में मैथुन से वायु बलवती हो योनि का पीड़न करती है। दक्षिण पार्श्व में लेटकर मैथुन करने से रस्तेष्वा च्युत होकर गर्भाशय को अवरोध कर देता है। उसी भाँति वामपार्श्व-स्थिति में मैथुन से पित्त पीडित हो च्युत होकर रक्त एवं शुक्र का विदह उत्पन्न कर देता है, अतः बीज-ग्रहण के लिए स्त्री को उत्तान लेटना चाहिए, जिससे सभी दोष यथास्थान स्थित रहते हैं।

महर्षि वाग्भट ने पुरुष को स्त्री के नीचे रहकर मैथुन करने का निषेध किया है, क्योंकि इस प्रकार करने से यदि पुत्र का जन्म हुआ तो वह स्त्री चेष्टा बाला एवं पुत्री पुरुष की चेष्टा वाली उत्पन्न होती है। इन्होंने भी मैथुन की विभिन्न स्थितियों का महर्षि चक्र सदृश ही अक्षरशः वर्णन किया है।

Coitus should not be done with a woman in her flexed (hump-back) or lateral position. In flexed position *vāyū* gets agitated and compresses the *yonī*, in right lateral position the *kapha* getting displaced obstructs the *garbhāśāyā*, similarly in left lateral position displaced *pitta* burns (*vidāha*) the *rakta* (ovum) and *śukra* (sperms), hence for reception of *bija* the woman should lie in supine position, so that all the *dōṣas* remain in their normal locations. The man should not lie below the woman, because after this postural copulation if woman delivers a male child, he will have feminine characters and if female child then she will have masculine habits.

विमर्श (Comments)

उपरिचर्चित स्त्री को शारीरिक स्थितियों में सम्भोग होने पर शुक्र का निषेचन यथास्थान न हो सकने अर्थात् अपूर्ण-सम्भोग होने की सम्भावना अधिक होती है, जिस स्थिति में गर्भाधान की सम्भावना कम हो जाती है।

Above mentioned postures of the woman during coitus may become like a incomplete coitus, in which chances of conception become very less.

गर्भाशय के लिए आवश्यक घटक (Factors essential for conception)

यद्योकेन विधिनेपसंस्कृतशरीरयोः स्त्रीपुरुषयोर्मिश्रीभावमापन्नयोः शुक्रं शोणितेन सह संयोगं समेत्याद्या-पत्रमव्यापनेन योनावनुपहृता^५, मप्रदुष्टे गर्भाशये गर्भमभिनिर्वर्तयत्येकान्तेन। यथा-निर्मले वाससि मुपुत्तिकलिते रज्जनं समुदितगुणमुपनिपातदेव गगमभिनिर्वर्तयति, तद्वत्; यथा वा क्षीरं दध्नाऽभिषुप्तमभिषवणाद्विहय स्वभावमापदते दधिभावं, शुक्रं तद्वत् ॥ (च० सं० शां० ८/१७)

ध्रुवं चतुर्णां सात्रिध्यात् गर्भः स्याद् विधिपूर्वकं। ऋतुक्षेत्राब्जुबीजानां सामग्र्यादङ्कुरो यथा ॥

(सु० सं० शां० २/३३)

निपातादेव गृह्णति रागं वासोयथाऽमलम्। ध्रुवं गर्भं तथा बीजं क्षेत्रं बीजमुपस्कृतम् ॥

(अ० सं० शां० १/६८)

शुद्धे गर्भाशये मार्गं रक्ते शुक्रेऽनिले हृदि। वीर्यवन्तं सुतं सूते ॥ (अ० ह० शां० १/८, ९,)

... ... ऋतुबीजकालमवक्षेत् ॥ (का० सं० शां० ५/५)

यथोक्त विधि के अनुसार उपसंस्कृत शरीर वाले स्त्री-पुरुष के संयोग से दोष-रहित शुक्र जब व्याधि-रहित योनि (मार्ग) से अतिकृत गर्भाशय में पहुँच कर, शुद्ध आर्तव के साथ मिलता है, तो अवश्य ही गर्भ रहता है, जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र सम्पूर्ण गुणों से युक्त रंग डालने पर अवश्य ही रंग ग्रहण करता है, अथवा दधि के साथ मिश्रित क्षीर अपना स्वभाव छोड़कर दही बन जाता है, उसी प्रकार शुक्र भी (आर्तव से मिलकर अपना स्वभाव छोड़कर गर्भ बन जाता है)।

महर्षि सुश्रुत ने धान्योत्पत्ति से गर्भाधान का सामञ्जस्य करते हुए बताया है कि जिस प्रकार ऋतु, बीज, क्षेत्र एवं अनुबु का सात्रिधय होने से धान्य का अङ्कुरण होता है, उसी प्रकार इनके संयोग से निश्चित ही गर्भाशय ही होती है। टीकाकार डल्हण ने इन चारों का स्पष्टीकरण करते हुए ऋतु से रजःकाल-समय, क्षेत्र से गर्भाशय, अनुबु से आहारपाकोत्पन्न रस-धातु एवं बीज से स्त्री तथा पुरुष बीज ग्रहण किया है। अन्यत्र अक्रान्तिम या शुद्ध आर्तव को ही गर्भकृत माना है, एवं अष्टावर्तदोष युक्त अथवा असुन्दर आदि को कृत्रिम आर्तव की संज्ञा दी है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने स्वच्छ वस्त्र की रङ्ग ग्राहता का उद्धरण देते हुए बीज से उपस्कृत क्षेत्र (स्त्रीबीज-युक्त गर्भाशय) एवं बीज (पुरुष-बीज) को ही प्रधानता बताई है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने गर्भाशय, मार्ग (योनिनलिका एवं डिम्बप्राणाली), रक्त (स्त्रीबीज), शुक्र (पुर्बीज), अनिल (अपान) १. ऋतुऽङ्गनाया रतः समयः, क्षेत्रं गर्भाशयः, अम्ल पुनसाहारपाकयो व्यापी रसधातुः, बीजं स्त्रीपुंसयोर्वनशुक्रौ॥ (सु० शां० २/३३ की डल्हण टीका)

२. गर्भकृच्चैति प्राकृतकर्मकथनम्। १. केचिन्वाचार्या 'रक्तलक्षणमार्तवं यथोक्तमक्रान्तिमं गर्भकृच्च' इति पठन्ति व्याख्यानायन्ति च यथोक्तमिति 'शशासुस्थितिं यच्च यद्वा लाक्षारसोपमम्' इत्याहुकलक्षणम्। अक्रान्तिमिति वातपित्तकक्षैरधः प्रसूतैष्टयाऽर्तवैश्वैः सुन्दररत्नतया वा कृतं कृत्रिमं, न कृत्रिममक्रान्तिं शुद्धं, गर्भकृच्चतीत्यर्थः॥ (सु० सं० सू० १५/५ की डल्हण टीका)

गर्भाधान-विधि

वायु एवं हृदय (पति-पत्नी को मानसिक स्थिति) को शुद्धता (स्वस्थता या दोष विरहितता) से वीर्यवान् पुत्रोत्पत्ति का वर्णन किया है।

कारणप्रसूतिताकार ने ऋतु की प्रधानता प्रदर्शित करते हुए ऋतुकाल एवं बीज (स्त्री एवं पुरुष-बीज) का प्राधान्य बताया है।

महर्षि भेल ने स्त्री एवं पुरुष के सामान्य हिलाहार आदि की उपादेयता का वर्णन करते हुए लिखा है कि जीर्ण हुए भोजन वाले, हित तथा मित-भोजी, अनुदावर्ता स्त्री-पुरुष में यदि गर्भ होता है तो वह बलवान्, वर्णवान् तथा चक्षुमान् आदि होता है। विपरीत होने पर विपरीत होता है। अन्यत्र महर्षि भेल ने गर्भाशय के अपदुष्ट होने तथा स्रोतस् के शुद्ध होने की भी गर्भाधान के लिए उपादेयता वर्णित की है।

When both male and female after observing the advocated dietetic regimen and other mode of life perform coitus and ejaculated unvitiated śukra, passing through healthy yoni, reaches healthy garbhāśaya and gets mixed with disease free śonita, then conception is definite, in the same way as a white cloth definitely takes up any dye; as milk mixed with curdling yeast changing original character forms curd, similarly śukra also gets changed (in the form of garbhā).

Suśruta equating germination of a seed with achievement of conception says that if yoni (season or period near ovulation or rīṭkāla), bīja (seed i.e. ovum and sperms), kṣetra (field i.e. female reproductive system) and ambu (water i.e. nourishing substances) assemble together, the conception will definitely occur.

Vāgbhata I has given the importance to kṣetra and bīja, while Vāgbhata II has emphasized that besides healthy garbhāśaya, mārga (vaginal canal), rakta (ovum) and śukra (sperms), properly functioning vāyu and normal psychological status (happy mood) are also essential.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सभी आचार्यों के वर्णनों में यद्यपि अन्तर दृष्टिगोचर होता है, परन्तु यदि विषय के समष्टि स्वरूप का अवलोकन किया जाय तो प्रतीत होगा कि स्थान-स्थान पर सभी आचार्यों ने स्त्री-जननांग, स्त्री एवं पुरुष-बीज, ऋतुकाल, पोषण तथा स्त्री एवं पुरुष की मानसिक स्थिति का गर्भाधान में प्राधान्य वर्णित किया है। महर्षि सुश्रुत एवं अष्टाङ्गहृदयकार ने उन्हें एक स्थान में संकलित कर वर्णन कर दिया है। महर्षि चरक के वर्णन में सभी संहिताओं में वर्णित विचारों का समावेश हो जाता है। शब्द-भेद से महर्षि चरक ने भी सुश्रुत द्वारा वर्णित चार घटकों का महत्व प्रदर्शित किया है यथा- जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज एवं ऋतु के संयोग से धान्य की उत्पत्ति सम्भव होती है, उसी प्रकार षड्धातु के संयोग

१. गर्भसंश्रयो गर्भाशयः, तस्मिन्। शुद्धे-निर्मले, बालादिभट्टे। तथा, मार्ग-प्रकृतत्वादपस्यमार्गं, बालादिभट्टे। तथा, रक्ते स्त्रीचरसि, शुद्धे तथा, शुक्रे-पुर्बीजे, शुद्धे। तथा, अनिले शुद्धे-पित्तादिभिन्नान्ते। तथा, हृदि शुद्धे-रोषानाभिहितेऽमलते ॥ (अ० ह० शां० १/८-९ की अरण्य टीका)

२. इह या स्त्रीः पुमांश्चैव जीर्णं हितमिताशनी। अनुप(दा)वर्तिना(नौ) चैव स्वातां गर्भस्तयोः खलु ॥ १५ ॥

बलवान् वर्णवर्धकश्च चक्षुष्माश्च भवत्यथा। विषयये वर्तमानो विपरीतमिहचितः(च्यति) ॥ १६ ॥ (धे० सं० सू० १२/५५ व १६)

३. इह खलु भोः याः स्त्रियः पथ्यलघुभोजिन्योऽनुदावर्तनशीला अपदुष्टा यथा गर्भाशयाः सुविशुद्धस्रोतसो भवन्ति, ता आचक्षतेऽवन्त्या कुशला इति। ता शृङ्खलं मेधावि चापलं जनयन्ति, विषयये विषययः॥ (धे० सं० शां० ८/१)

से गर्भ की उत्पत्ति हुआ करती है। कर्षण शब्द से टीकाकार चक्रपणि ने कर्षण से संस्कारित भूमि के ग्रहण का निर्देश दिया है। यद्यपि इस वर्णन में गर्भ के लिए षड्धातु को अनिवार्य माना है परन्तु जल आदि को भी माना जा सकता है।

In summarizing the above description it can be said that for achievement of conception, proper functioning *vāyu* (nervous system), normal psychology, healthy and properly functioning female reproductive system, well prepared uterus, healthy sperms and ovum are essential factors. Caraka has also accepted four factors just like Suśruta, albeit in indirect way. He says that as with water, ploughed field, seed and season the procurement of cereals is definite, similarly with union of *sadliṭā*, achievement of *grābha* is definite. Here, water etc. also can be considered for achievement of conception.

पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति के लिए संयोग-दिवस (The days of coition for having a male or female child)

स्नानात् प्रभृति युग्मेष्वहःसु पुत्रकामौ, अयुग्मेषु दुहितुकामौ । (च० सं० शा० ८/५)
विकल्पैव चतुर्थ्या षडशामष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकामः ॥ २८॥

अतः परं पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च स्त्रीकामः । त्रयोदशीभूतयो निश्चाः ॥ ३०॥

(यु० सं० शा० २/२८, ३०)

युग्मेषु तु पुमान् प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽजला । पुष्पकाले शुचिस्तस्मादपत्याथी स्त्रियं व्रजेत् ॥

(यु० सं० शा० ३/१२)

ततः स्नानात्पुनरापि गुणवत्पुत्रार्थं चतुर्तामृषेक्षेत । पुष्पदिनास्तस्मात्पुत्र ॥ ४७॥

अश्लिष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां वा रात्रौ पुत्रकामः संविशेत् । पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यां वा दुहितुकामः ॥ ४८॥
एकादशीत्रयोदश्योस्तु नपुंसकं स्यात् ॥ ५२॥ (अ० सं० शा० १/४७, ४८ व ५२)

ऋतुस्तु द्वादशनिशाः पूर्वोस्तिवोऽत्र निर्दिताः ॥

एकादशी च युग्मासु स्यात्तुषोऽन्यासु कन्यका ॥ (अ० ह० शा० १/२७ व २८)

युग्मेष्वहःसु पुत्रकामोऽन्यत्र कन्यार्थी दृष्टितस्तुषोऽनुबद्धः (अनुक्तः-शु० पा०) स्त्रियमुपेयादिति

सिद्धम् ॥ (का० सं० शा० ५/६)

महर्षि चरक ने युग दिवसों में संयोग से पुत्र तथा अयुग दिवसों में संयोग से कन्या की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

महर्षि सुश्रुत ने रजःस्राव के बाद शुद्ध हो, पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति के प्रयत्न में युग एवं अयुग दिनों की चरक-प्रतिपादित विचारणा का समर्थन करते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी एवं द्वादशी में पुत्र तथा पञ्चमी, सप्तमी, नवमी तथा एकादशी में गर्भाधान होने से कन्या उत्पन्न होगी। त्रयोदशी आदि निश्चय हैं।

अष्टांगसंग्रहकार ने गुणवान् पुत्रोत्पत्ति के लिए स्नान के पश्चात् चार रात्रि अर्थात् रजःस्राव प्राप्त होने के पश्चात् सात रात्रि तक संयोग न करने का आदेश दिया है। यह भी लिखा है कि अष्टमी, दशमी में संयोग से पुत्र, पञ्चमी, सप्तमी और नवमी में गर्भाधान से पुत्री तथा एकादशी एवं त्रयोदशी में गर्भाधान से नपुंसक की उत्पत्ति होगी।

अष्टांगहृदयकार ने बारह दिन के ऋतुकाल में अयुग रात्रि की विचारणा का समर्थन करते हुए पहिले की तीन रात्रि एवं एकादशी को निषिद्ध बताया है। टीकाकार अरुणदात्त ने 'च' शब्द से त्रयोदशी को भी निषिद्ध माना है, क्योंकि

१. जलकर्षणबीजसंयोगात् संयत्संभवः युक्तिः षड्धातु संयोगादुर्भावां संपवत्तथा॥
(कर्षण शब्देन कर्षणसंस्कृता भूमिर्गृहीते-चक्र०) (च० सं० सू० ११/२३ एवं चक्र० टीका)

इस दिन संयोग होने से नपुंसक की उत्पत्ति का संभावना रहती है।^१

महर्षि काश्यप ने भी लिखा है कि पुत्रेच्छा में युग दिनों में तथा कन्यार्थी अन्य दिनों में, हर्षित (प्रसन्न), तृप्त (सन्तुष्ट) तथा अनुरुद्ध (अनुरक्त अर्थात् अपनी पत्नी के प्रति अग्रागण रखने वाला) होकर स्त्री के साथ सहवास करे।

महर्षि भेल ने भी षष्ठी, अष्टमी आदि में गर्भाधान होने पर पुत्र तथा पञ्चमी आदि में कन्या की उत्पत्ति का वर्णन दिया है।^२

आचार्य भवमिश्र ने भी युग एवं अयुग रात्रियों में क्रमशः पुत्र या कन्या की उत्पत्ति का वर्णन दिया है।^३

With the coitus done on even days the born child would be male and with odd days it would be a female. On *catuṛthī*, *asthamī*, *daśamī* and *dvādaśī* it would be a male and on *pāñcamī*, *saptamī*, *navamī* and *ekādaśī* it would be a female. *Tryoḍaśī* etc. are contraindicated dates for coitus. According to Vāgbhata I a person desirous of having an offspring of high qualities should not have coitus for three days in *rūkāla* (upto 7th day of menstruation). The child conceived on *ekādaśī* and *tryoḍaśī* would be *nāpūṃsaka* (hermaphrodite).

विमर्श (Comments)

इस सन्दर्भ में वर्णित चतुर्थी, षष्ठी आदि तिथि-बोधक न होकर ऋतुकाल के दिनों के बोधक हैं अर्थात् चतुर्थी या षष्ठी से ऋतुकाल का चौथा या छठवाँ दिन समझना चाहिए।

These *catuṛthī* etc. should not be considered as specific days of lunar month, rather the days after onset of menstruation.

युगमायुग दिवसों में संयोग से पुत्र या पुत्री के जन्म का कारण (The Cause of birth of male or female on even or odd days respectively)

तत्र युग्मासु रात्रिचत्वारिंशत्वारिंशत्तयुगमास्वाप्यायते । तस्मात्तासु क्रमादुत्पन्न दुहितुश्च जन्म । अतएव चानुपरततर्वदश्यां पुत्रार्थी विषमेष्वहस्तसु नोपेयात् ॥ ५०॥

यदि त्वाहाराशुषाद्युग्मासु शुक्रस्याधिकता युग्मासु च न्यूनता स्यात् ततः पुमान् स्थानकृतिर्दुर्बलो हीनान्द्रो वा जायते । स्त्री च पुरुषाकृतिर्दुर्बला हीनान्द्रो वा ॥ ५१॥ (अ० सं० शा० १/५०, ५१)

युग रात्रियों में आतव अल्प होता है एवं अयुग रात्रियों में बढ़ता है, अतः क्रमशः पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। अतः आतव-दर्शन हो चुकने वाली स्त्री के साथ पुत्रार्थी व्यक्ति विषम दिनों में भी (अर्थात् विषम दिनों में दिन के समय भी) सहवास न करे।

१. च शब्दोऽशुक्रायास्त्रयोदश्याः समुच्चयार्थः त्रयोदश्यां हि मिथुनेभावे नपुंसकस्योत्पत्तिरिति कैचिदाहुः॥

(अ० ह० शा० १/२७-२८ की अरुण० टीका)

२. निषिद्धि (ते) तु त्र्यहणे पुराणे लघिरे, (स्य) वसिते (च) शुद्धस्नातायाश्चतुर्थपञ्चाष्ट (म) दशमद्वादशसु (शेषु) अहस्तसु गर्भवत् (प) क्रममा (मणे) ण (न) पुमान् भवति पञ्चमसप्तमनवै (वर्गै) कादशसु (शेषु) स्त्रीत्वायोपकस्यते॥ (भे० सं० शा० ५/५५)

३. युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/२२)

Afterwards (after menstrual flow is over) the preceptor should guide for specific rituals and the wise person (husband) should start the rituals described further.

(आ) शुद्धा के लिए मंत्र-प्रयोग निषेध (Contraindication for use of hymns by *śūdra* or *untouchable woman*)

शुद्रा तु नमस्कारमेव कुर्यात् (देवाग्निविष्णुशिवसिद्धेश्वरः) ॥ (च० सं० शा० ८/१३)
शुद्रायस्तु मन्त्रवर्जितम् । (अ० सं० शा० १/५३)

नमस्कारपरयास्तु शुद्राया मन्त्रवर्जितम् ॥ (अ० ह० शा० १/२९)

शुद्र जाति की स्त्री को लिए मंत्र-प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। उसे देव, अग्नि, ब्रह्माण, गुरु, तपस्वी एवं सिद्धजनों को केवल प्रणाम करने का विधान है ।

A *śūdra* should not use hymns, perform only obeisance to god, fire, *brāhmaṇa*, preceptor, devout and celebrated persons.

(इ) पूर्वकर्म एवं संयोग-विधि (Method of conjugation and its prior acts)

अथाप्येतौ स्त्रीपुंसौ स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्य, वमनविरचनाभ्यां संशोध्य, क्रमेण प्रकृतिमापादयेत् । संशुद्धौ चास्यापानानुवासनाभ्यामुपपाचेत् उपपाचेच्च मधुरौषधसंस्कृताभ्यां घृतक्षीराभ्यां पुरुषं, स्त्रियं तु तैलमाषाभ्याम् ॥ ४॥ संज्जातदहौ मैथुने यानुकूलाविष्टाभ्यां स्वास्तीर्णं सुखं शयनमुपकल्प्य मनोज्ञं हितमश्रममश्रित्वा नात्यशितौ दक्षिणपादेन पुमानरोहद् वामपादेन स्त्री ॥ ७॥ (च० सं० शा० ८/४, ७)

ततोऽपराह्णे पुमान् मांसं ब्रह्मचारी सर्पिःस्निग्ध सर्पिःक्षीराभ्यां शात्योदनं भुक्त्वा मांसं ब्रह्मचारिणीं तैलस्निग्धं तैलमाषोत्तराहारां नारीमुपेयात् रात्रौ सामादिभिरभिचिक्षास्य ॥ (सु० सं० शा० २/२८)

कर्मान्ते च पुमान्मांसं ब्रह्मचारी सर्पिःक्षीराभ्यां शात्योदनमभिप्राप्य नात्याशितः सुखी स्वामी सुमनाः प्रीणितान्द्रुः शुक्लनिवसनो मौहूर्तिकापुमने रात्रिभोगे कल्याणानि चिन्तयन्स्तदधिकारः स्वास्तीर्णं शयनं दक्षिणेन पादेन प्रणारोहेत् । तद्विधैव च प्रमदा कर्षिताङ्गी तैलमाषोत्तराहारा पूर्वं वामपादेन पुरुषस्य दक्षिणतः शय्यामधिरोहेत् ॥ ५४॥

ततः परस्परं सामभिर्ममिमास्तस्य सहर्षमनुकूलं संवसेताम् । पयसि चैनां शीतोदकेन सहसा परिधिञ्चेत् ॥ ५७॥

सौम्याकृतिवचनोपचारवेष्टाश्च प्रियहितानुवर्तिनः परिचारकास्तथा भर्तृति ॥ ६३॥

पुनश्चैनां मासदुपेयात् ॥ ६४॥ (अ० सं० शा० १/५४, ५७, ६३ तथा ६४)

स्नेहैः पुंसवतैः स्निग्धं शुद्धं शीतलवस्तिकम् । नरं विशेषतश्क्षीराभ्यामधुरौषधसंस्कृतैः ॥ २०॥
नारीं तैलेन मधैश्च भिन्नतैः समुपाचेत् ॥ २१॥

कर्मान्ते च पुमान् सर्पिःक्षीराभ्यामोदनाशितः । प्रादक्षिणेन पादेन शय्यां मौहूर्तिकाजया ॥ ३२॥
आरोहेत् स्त्री तु वामेन तस्य दक्षिणापार्श्वतः । तैलमाषोत्तराहारा तत्र मन्त्रं प्रयोजयेत् ॥ ३३॥

सान्त्वयित्वा ततोऽन्यत् संविशेतां मुदाच्यते । उताना तमना योषितिशेदङ्गैः सुसंस्थितैः ॥ ३६॥

तथा हि बीजं युद्धाति दोषैः स्वस्थानमास्थितैः ॥ ३७॥ (अ० ह० शा० १)

स्नेहस्वेदवमनविरचनास्यापानानुवासनैः क्रमशः उपपाचेन्मधुरौषधसिद्धाभ्यां क्षीराघृतसुष्टं पुरुषं, स्निग्धं तु तैलमांसं (माषा)भ्यामित्येके, सान्त्वयैवेति प्रजापतिः ॥ ३॥

..... कल्याणमानाश्च स्यात् । न तु सन्ध्ययोः स्नानं मैथुनं वोपेयान्नाप्यमना इति ॥ ७॥

(का० सं० शा० ५/३ व ७)

महर्षि चक्र ने स्नेहन-स्वेदनादि का वर्णन करते हुए लिखा है कि इसके पश्चात् (ऋतुसाव के पश्चात्) स्त्री एवं पुरुष को स्नेहन-स्वेदन कर, तत्पश्चात् वमन-विरचन के द्वारा शरीर को शुद्धि कारक क्रमशः प्राकृतिक अवस्था (आहार आदि) में ले आवें । शोषण के पश्चात् यथारिधि आश्रयण एवं अनुवासन वस्ति का प्रयोग करें, तत्पश्चात् पुरुष को मधुर (वर्ग की) औषधियों से सिद्ध घृत एवं क्षीर तथा स्त्री को तैल एवं माष का सेवन करावें ।

शरीर में हर्ष एवं मैथुनेच्छा होने पर प्रिय गन्धों से युक्त सुककारी शय्या पर सुककारी बिस्तर बिछाकर, मनोनुकूल हित भोजन कर एवं अत्यधिक भोजन न कर, दक्षिण पैर से पुरुष एवं बाँयें पैर से स्त्री (शैय्या में) आरोहण करें । मैथुन के पश्चात् शीतोदक से परिषेचन करें ।

महर्षि सुश्रुत के मतानुसार तत्पश्चात् (पुत्रोष्टि यज्ञ के पश्चात्) एक मास तक ब्रह्मचर्य रहता हुआ घृत-स्निग्ध पुरुष अपाह्न में घृत एवं क्षीर के साथ शरीरि वाचल के भात का भोजन कर, एक मास तक ब्रह्मचारिणी, तैल से स्निग्ध तथा तैल एवं माष-भूयिष्ठ आहार का सेवन की हुई स्त्री के साथ साम आदि से आश्रयण देकर रात्रि में सहवास करें ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने सुश्रुत के मत का अनुमोदन करते हुए लिखा है कि पुत्रोष्टि विधि की समाप्ति पर, एक मास का ब्रह्मचारी पुरुष क्षीर एवं सर्पि के साथ शात्योदन खाए, अत्यधिक न खाए, फिर प्रसन्नचित्त, पुष्पों की माला से विभूषित, नियोग एवं स्वस्थ आंगोवाला पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर, महूर्त का विचार कर, रात्रि के कल्याणकारी भाग में उसकी (स्त्री की) चिंतना करते हुए, बिछाई हुई शय्या पर पड़िते दक्षिण पैर से आरोहण करें, उसी भाँति कर्शित अंगों वाली, विशेष रूप से तैल एवं माष का भोजन की हुई स्त्री प्रथम बाँयें पैर से पुरुष के दक्षिण की ओर शैय्या में आरोहण करें ।

अन्यत्र लेखक ने लिखा है कि परिचायक एवं पति स्त्री के साथ सौम्य आकृति, सौम्य वचन, सौम्य उच्चार एवं वेश करें । पुनः एक मास बाद (ऋतुसाव होने के बाद) सहवास करें ।

तत्पश्चात् परस्पर साम आदि से सान्त्वना देकर, हर्ष होने पर सहवास करें । उसके पश्चात् स्त्री शीतल जल से सहसा (तत्काल ही) परिषेचन करें ।

अष्टांगहृदयकार ने लिखा है कि स्नेहों में (फलघृत या महाकल्याणघृत से) स्निग्ध तथा शुद्ध (वमन विरेचनान्दि से शुद्ध^१), मैथुन के अभ्यास में अनुष्ठित पुरुष मधुरौषध से^२ साधित क्षीर एवं घृत आदि का प्रयोग कर तैल, माष एवं पित्तल आहार सेवित स्त्री से सम्भोग करें, एवं इन्होंने भी अष्टांगसंग्रह-वर्णित शैय्या-आरोहण आदि का वर्णन किया है, (पुरुष के वस्त्र-माला आदि का वर्णन नहीं है), तथा लिखा है कि स्त्री को उत्तान स्थिति में शयन करना चाहिये, क्योंकि उससे दोषों की यथास्थान स्थिति हो समुचित रूप से बीज-ग्रहण होता है । वैसे तो सभी आचार्यों ने एक मास ब्रह्मचर्य के बाद ही सम्भोग का वर्णन किया है, पर इन्होंने तो स्पष्ट रूप से केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही एकांत में सम्भोग करने का निर्देश दिया है (जिससे उत्तम संतानोत्पत्ति होती है) । महाकूलोत्पन्न भी दुष्ट संतान कुल के लिये अंगार होती है ।

महर्षि काश्यप के मतानुसार स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आश्रयण एवं अनुवासन से क्रमशः शुद्ध, मधुरौषध-सिद्ध क्षीर एवं घृत से पुष्ट पुरुष, तैल तथा माष सेवित स्त्री के साथ सहवास करें । स्त्री मन से कल्याण या सुख चाहने वाली हो, अन्य पुरुष को चाहने वाली न हो । दोनों सान्त्वकाल (प्रातः एवं सायं) में मैथुन एवं स्नान नहीं करना चाहिए ।

१. पयसि चैनां शीतोदकेन परिधिञ्चेत् ॥ (च० सं० शा० ८/६)

२. स्नेहैः पुंसवतैः-यथाभिमतार्थग्रहणभावैः फलसर्पिर्महाकल्याणकादिभिः, स्निग्धम् तथा, शुद्धं-कुलवमनविरचनम् तथा शीतलवस्तिकम्, शीतलिताः अभ्यासेनानुष्ठिताः, वस्तयो येन-मैथुनेन, तच्छीतलवस्तिकम् ।

(अ० ह० शा० १/२० की अरुण० टीका)

३. सन्तो ह्यहुरत्यार्थं दम्पत्योः सङ्गतिं रहः। दुरपत्यं कुलाङ्गीरो गोधे जातं महत्स्थिति। (अ० ह० शा० १/३०)

आचार्य भावमिश्र ने शब्द भेद से उपर्युक्त आचार्यों के ही विचारों का प्रतिपादन किया है,^१ एवं इन्होंने गर्भधारण के लिये संसर्ग के पश्चात् एक मास तक पुनः संसर्ग न करने का निर्देश दिया है। सुश्रुत एवं वाग्भट के 'मास ब्रह्मचारी' शब्द का भी यही अर्थ है, कि एक बार गर्भधारण के लिये संयोग कर द्युबारा पुनः ऋतुस्त्राव के पश्चात् गर्भ-प्राप्ति के लिए ही सहवास करें। परन्तु आचार्य भावमिश्र जी ने कारण का मध्यिकरण करते हुये लिखा है कि यदि गर्भधारण हो गया तो गर्भशयन द्वारा में धक्का लगने से गर्भव्युति की संभावना रहती है, अतः पुनः अर्तव-दर्शन से गर्भधारण नहीं हुआ ऐसा निश्चित होने पर ही दुबारा सहवास करें। गर्भधारण हो जाने पर सहवास न करें।^२

टीकाकारों ने पुरुष द्वारा यूरालि तथा स्त्री द्वारा तैलादि के प्रयोग के विधान का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि मधुर आदि द्रव्य शुक्र-वृद्धिकारक होते हैं, तथा तैल एवं पित्तल द्रव्य रक्त-वृद्धिकारक होते हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने स्त्री को तैलादि के साथ क्षीरदि के प्रयोग का भी विधान प्रारम्भ में बताया है, परन्तु बाद में उसके प्रयोग का निषेध है^३ (पित्तवृद्धि-कारक द्रव्य गर्भसाव-कारक हो सकते हैं)।

After menstruation i.e. 4th day onwards the couple after being purified by use of oleation, sudatory measures, emetics, purgatives and brought to normal condition (dietetics) should be given *āsāhāpama* (evacuative enema) and *anuvasana* (nutritive enema) *basti*. After these purifying measures, the man should use the *ghṛta* and milk medicated with the drugs of *mādhura varga* (sweet or anabolic drugs) and the woman should consume oil and *māṣa* (a sort of kidney bean). The couple having feeling of carnal relation, avoiding over eating but consuming desirous beneficial food should go to the comfortable cot spreaded with soft mattress and sprinkled with pleasant fragrance. The man should go to the bed by keeping his right leg first while the woman the left one. After coition they should irrigate (wash the genital organs) with cold water.

Sūśruta opines that the man properly oleated with *ghṛta*, having observed celibacy for one month, after taking *śālī* rice with *ghṛta* and milk in the afternoon should have sex plays and coitus in the night with the woman properly oleated with oil having observed chastity for one month and taken food prepared mainly with oil and *māṣa*.

Vāgbhaṭa agreeing with the above view elaborates that a healthy man possessing

१. स्नातश्चन्दनसिक्नः सुगन्धसुमनोऽर्चितः। भुक्तवृष्यः सुवसनः सुवेशः समलङ्कृतः॥ २२॥

ताम्बूलवदन्तस्यामनुकोऽधिकस्मरः। पुत्रार्थं पुरुषो नारीमुपेयाच्छने शुभे॥ २३॥

अन्त्याशितोऽधृतिः क्षुद्रान् सव्यथाङ्गः पिपासितः। बालो वृद्धोऽन्येनार्तस्त्यजेदनी च भैरुनम्॥ २४॥

पुरुषस्य गुणैर्दुका विहिता न्यूनभोजना। नारो ऋतुमती पुंसं सांछेत्सु सुताक्षिनी॥ २५॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/२२ से २५)

२. एवं ताम्बिसङ्गम्य पुनर्मसार्द भवेदत्तां॥ २६॥ मसार्दव्यंमिति शेषः। अर्वागमनेन गर्भदाविषद्वन्द्वं गर्भव्युतिप्रसङ्गः स्यात्, केचित्तु, पुनः पुष्पदर्शनेन गर्भालम्बनक्षये मसार्दवर्धं गच्छेद्, तत्त्वगर्भे नैव गच्छेदिति वदन्ति। (पा० प्र० पूर्व० ३/४१)

३. (अ) मधुरस्य विशेषेण शुक्रवृद्धिकारत्वात् (च० सं० शा० ८/४ की चक्र० टीका)

(आ) पित्तलानि हि रक्तवृद्धि हेतवः। एवं च तैलं पित्तकृत्वादेवोपन्यस्तम्। विशेषादित्यन्यनुवर्तते।

क्षीराभ्येभ्योऽपि विशेषेण नारो तैलादिभिः समुपाचरोत्तर्यः। पुरुषस्य तु रजसोऽभवात्तद्वृद्धिहेतवस्तैलादयो नोपयुज्यन्त एव।

(अ० ह० शा० १/२०, २१ की अरण्य० टीका०)

(३) उत्तराश्वेऽत्र तैलमाधौ पित्तलो रक्तवृद्धिहेतुत्वाऽस्त्यन्तं सेवितव्यौ। न पुनस्तथा शुक्रवृद्धिकारणान्यापि क्षीरानि दिव्याणीति प्रतिपादयति। (अ० ह० शा० १/३३ की अरण्य० टीका)

healthy organs should be in high spirit, adorn himself with garland of flowers and psychologically thinking only about his wife should have coitus in appropriate auspicious period of night with the woman emaciated by specific dietetic regimen. Husband and other attendants should wear happy faces, use polite words and do gentle behaviour and acts with the woman (for whole month).

Vāgbhaṭa has specified the *ghṛtas* as *phalaḥghṛta* and *māhākalāyāna ghṛta* and besides above mentioned diet for woman advocates the use of edibles by woman capable of increasing *pitta*. He has specifically indicated the coitus to be performed in seclusion exclusively for reproduction (so that one gets a good progeny). The progeny with bad character even if born in high family destroys the reputation of whole family.

Kāśyapa stresses that woman should be wanting of happiness and pleasure psychologically, she should love only her husband none the else. In dawn and twilight coitus and bath should not be done.

Bhāwaprakāśa clarifying the reason for observance of celibacy for remaining period of month after initial coitus says that if conception has taken place, then jerks to *garbhāśraya-nukha* (cervix uteri) caused by coitus can initiate abortion, hence, on being sure about absence of pregnancy by reappearance of menstruation the subsequent coitus should be done.

The commentators have explained that *mādhura* drugs increase *śukra* and *pitta* drugs increase *rakta*. Arunadatta clarifies that initially the woman should also be given milk etc. alongwith oil etc., however, later on these should not be used (*pitṭavaradhaka* drugs can initiate abortion).

(ई) संयोग के समय प्रयुक्त मंत्र (The hymn to be recited before coitus)

तत्र मन्त्रं प्रयुञ्जीत 'अहिंसि अयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वा दधातु विधिता त्वा दधातु ब्रह्मवर्चसा भव' इति।

ब्रह्मा ब्रह्मस्मतिर्विष्णुः सोमः सूर्यस्तथाऽश्विनौ। भगोऽथ मित्रावरुणौ वीरं ददतु मे सुताम्॥

इत्युक्त्वा संवसेयाताम्॥ (च० सं० शा० ८/१० व ८)

तत्र मन्त्रं प्रयुञ्जीत-अहिंसि वीरं दधातु मे सुत। इति॥

(अ० सं० शा० १/५५ व ५६; च० सं० सद्गुष्टा ही)

अहिंसि धाता। त्वा त्वां ब्रह्मवर्चसा भवति। ब्रह्मा ... सुताम्॥

(अ० ह० शा० १/३४ व ३५; च० सं० सद्गुष्टा)

इस मन्त्र का प्रयोग करें, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है—(हे गर्भ) तुम सूर्य के समान हो, तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो। धाता (धारण करने वाला ईश्वर) एवं विधाता (विश्व के निर्माता ब्रह्मा) तुम्हारी रक्षा करें। तुम ब्रह्मा से युक्त होओ।

ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, अश्विनीकुमार और मित्रावरुण जो दिव्य शक्तिरूप हैं वे मुझे वीर पुत्र प्रदान करें। इस मंत्र को पढ़कर सहवास करें।

Following hymn should be recited just before the coitus: (O *garbha*) you are like sun, you are my longevity, you are my prestige by all means. *Dhātā* (god of protection) and *vidhātā* (the god of creation) should protect you. You should have *brahman* in you.

Lords *brahman*, *bṛhaspati*, *viṣṇu*, *soma*, *sūrya*, *aśvinikumarā* and *mītravaruṇa* having divine powers bless me with courageous son.

(३) पुत्रोष्टि यज्ञ की विधि (The method of performing *putresṣi yajña*)

ततः ऋत्विक्, प्रातःपूर्वम् दिश्यानास्य प्राक्प्रवणमुदम्भवणं वा प्रदेशमभिमुख्य, गोमयेदकाभ्यां स्थण्डिलमुपलिप्य, प्रोक्ष्य चोदकेन, वेदीमस्मिन् स्थापयेत् । तं पश्चिमेनान्वत्तस्त्रसङ्घे श्वेताभ्यं वाऽप्यजिन उपविशेद् ब्राह्मणप्रयुक्तः, राजन्यप्रयुक्तस्तु वैवाधे चर्मयानडुहे वा, वैश्यप्रयुक्तस्तु शैवे बाले वा । तत्रोपविष्टः पालाशीभैरङ्गुलीभिरदुर्व्यतीर्णमण्डूकीभिरां समिद्धिरिन्मृगसमाधाय, कुशैः परित्तीर्णं, परिधिभिश्च परिधाय, तान्बैः शुक्लाभिश्च गन्धवतीभिः सुमनोभिरुपकलेत् । तत्र प्रणीयोदपात्रं पवित्रपूतमुपसंस्कृत्य सर्पिरान्व्याधं यथोक्तवर्णा-नाजानेयदीन् समन्ततः स्थापयेत् ॥ १० ॥

ततः पुत्रकामा पश्चिमतोऽग्निं दक्षिणतो ब्राह्मणमुपविश्यान्वात्तभेत सह भार्या यथेष्टं पुत्रमाशासना । ततस्तस्या अशासानाया ऋत्विक् प्रजापतिमभिनिर्दिश्य योनौ तस्याः कामपरिपूरणार्थं काम्यामिष्टिं निर्वर्तयेद् 'विष्णुर्योनिं कल्पयतु' इत्यनयवा । ततश्चैवायमेन स्थालीपाकमभिधाय त्रिर्बुध्वाद्याशान्यायम् । मन्त्रोपमन्त्रितमुदपात्रं तस्मै दद्यात् सर्वोदकाशान् कुरुञ्चोति । ततः समासे कर्मीणं पूर्वं दक्षिणपादमभिहरन्तीं प्रदक्षिणामग्निमुपरिक्रामेत् सह भार्या । ततो ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वाऽऽन्यशेषं प्राश्यात् पूर्वं पुमान्, पश्चात् स्त्री, न चोच्छिष्टमन्यशेषयन्तं ततस्तौ सह संवसेयतामभ्युष्टां, तथाविधपरिच्छदवेव च स्यातां, तथेष्टपुत्रं जनयेताम् ॥ ११ ॥

(च० सं० शा० ८/१०, ११)

ततः ऋत्विक्, पुत्रोयामिष्टिं निर्वर्तयेत् । सिद्धमांसोदा वाताघ्नौ (?) वाऽऽन्यभागौ, यक्ष्मयः पुरोडाशोऽष्टकपालौ, ब्रीहिमयश्चक्रः, उभौ वागायुतौ प्रजापयेत्, न त्वदेक्षे, 'अब्राह्मणब्राह्मण' इति यजमानसामगमभिमन्त्र्य शेषं दम्पती प्राश्रियाताम् । श्वेत ऋषभोऽश्वो वा हिरण्यं वा भिषग्वे सैव दक्षिणा, सैवमनाहिताने, शालाननी नित्यं होमं हुत्वा, तैव मन्त्रेण हुतशेषं तौ प्रां श्रितः । शयनीये मृदुस्वास्तीर्णोपहितेऽस्य भर्ता न लक्षणागमिद्धिरालोड्य 'सोमः पवन' इत्येतेन शतजनेन सवित्र्या व्याहृतिभिः 'अपो देवीरुपसृज' इति मन्त्रेण नस्यं दत्त्वा, वामदेव्यं जपित्वा, दक्षिणेन पाश्वेन स्थित्यं श्राययीत, वामपाश्वेन पुमान्पुत्रोत्तरेणोपशयीत । शनैः प्रजार्थं चाचरेत् । बीजेऽवसिक्ते विधायार्वावसयेत् । शीतोदकेन च शौचं कुर्यात् । तत ऊर्ध्वमग्निर्कर्मप्रतापाया-सव्यायामशोकादिवर्जनीमिति । (का० सं० शा० ५/८)

इसके पश्चात् ऋत्विक्, गृह की पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूर्व या उत्तर में ही प्रवृण (निम्न) स्थान को देखकर, उस पूजन स्थान को गोबर एवं जल से लीपकर, पुनः जल से पोंछकर वेदी की स्थापना करे । पश्चात् ऋत्विक्, उस वेदी के पश्चिम भाग में यदि यजमान ब्राह्मण हो तो बिना फटे (नए) वस्त्रों के समूह से बने या श्वेत वृषभ के चर्म से बने आसन पर, क्षत्रिय हो तो व्याघ्र या वृषभ के चर्म से बने एवं यदि वैश्य हो तो मृग (रस) या बकरी के चर्म से बने आसन पर बैठे । वहाँ वैठकर पलाश, इंगुदी, उदुम्बर या मधुक की लकड़ियों (समिधाओं) से अग्नि का उपसमाधान (स्थापना) कर, कुशाओं को चारों ओर फैलाकर, (वेदी को) चारों ओर से सजकर, लाज तथा सुगन्धित एवं श्वेत पुष्प सभी तरफ बिखेर दे । तब मन्त्रादि द्वारा पवित्र एवं उपसंस्कृत (स्वच्छ), प्रणीय (पवित्र) उदक पात्र एवं हवन के लिए घृत (वेदी के पास) रखे एवं जिस वर्ण के पुत्र की इच्छा हो उस वर्ण के बोड़े आदि (अन्य सजावट की सामग्री) चारों ओर रखे । इसके पश्चात् यथेष्ट पुत्र की आकांक्षा वाली स्त्री, अग्नि के दक्षिण भाग में ब्राह्मण को बैठकर, स्वयं पति के साथ अग्नि के पश्चिम भाग में बैठे, एवं ऋत्विक् की आज्ञा का पालन करे । तब उस स्त्री के मनोरथ की पूर्ति के लिये स्त्री

की योनि में प्रजापति का निर्देश कर 'विष्णुर्योनिं' आदि ऋचा का पाठकर काम्य-इष्टि (पुत्रोष्टियज्ञ) का प्रारम्भ करे । पश्चात् स्थाली में चरु को पूर्वाभिर्मन्त्रित घृत से मिलाकर यथवेद (जो जिस वेद का मानने वाला हो) विधि से तीन बार आहुति दे । फिर मन्त्र से उपमन्त्रित जल-पात्र को उस स्त्री को दे दे, एवं जल के सभी कार्य इसी पात्र के जल से करने का निर्देश दे । इस यज्ञ-कर्म के समाप्त होने पर, अपने दाहिने ओर अग्नि को रखती हुई, पहिले दाहिना पैर उठकर पति के साथ प्रदक्षिणा करे । तत्पश्चात् ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर हवन से बचे हुए घृत की पहिले पुरुष चार में स्त्री पिप्पु, उसमें जच्छिष्ट (जूठा) न छोड़े । इस प्रकार आठ यात्रे तक सहवास करे । जिस प्रकार के वस्त्र आदि का प्रयोग करेगे उसी प्रकार के पुत्र को उत्पन्न करेंगे ।

महर्षि काश्यप ने भी यज्ञ-विधि का वर्णन किया है परन्तु वह उच्युक्त वर्णन से कुछ वैभिन्न रखती है । इसके बाद ऋत्विक् पुत्रोष्टि यज्ञ को करे । हवन करने के लिये सिद्ध मांस, ओदन, वातन औषधि, आठ कपालों में संस्कृत यव का पुरोडाश एवं ब्रीहि (धान्य) से युक्त चरु (समिधा) को तैयार करे । इससे पति पत्नी दोनों वाणो और आयु से युक्त हो जाते हैं । फिर 'आब्राह्मणब्राह्मण' आदि मन्त्र से यजमान के भग्न को अभिमन्त्रित करके शेष भाग को दम्पति खाये । श्वेत वृषभ या अश्व अथवा हरिण अनर्हतिर्गिन वैद्य को दक्षिणा दें । शालागिन में नित्य हवन कर, उसी मंत्र से अभिमन्त्रित, हवन से शेष बची सामग्री नित्य भोजन करें । इसके बाद पति पुत्र, सुखकर बिस्तर पर पत्नी को लिटाकर, लक्ष्मणा (औषधि) को पत्नी में घोलकर 'सोमः पवन' मंत्र सौ बार जप कर, सावित्री मंत्र को कह कर, 'अपोदेवीरुपसृज' मन्त्र द्वारा नस्य देकर, वामदेव्य (ऋषि वामदेव के वंशज) का जाप कर, दक्षिण पाश्व में स्त्री को शयन करावे । वाम पाश्व से पुष्प ऊपर (स्त्री के) लेटे, एवं संज्ञान प्राप्ति के लिए धीरे धीरे आचरण (मैथुन) करे । बीज (शुक्र) के अवसिक्त हो जाने पर स्त्री उसे धारण कर पृथक् हो जाय, पश्चात् शीतल जल से प्रक्षालन करे । तत्पश्चात् अग्निकर्म (अग्नि के पास काम करना), तैज धूप, अधिक परिश्रम, व्यायाम एवं शोक का परित्याग करे ।

Only two authors i.e. Caraka and Kāśyapa have described the detailed methods of *putresṣi yajña* which is actually a subject of sociology or religion. The methods of both these authors differ considerably.

Now the priest should search a space in the north or east direction of the house (court-yard) which is slopy towards north or east, besmear it with cow-dung and water, rewrite the same with water and establish an altar. Now the priest should sit on the west side of that altar over a cushion made with new cloths or over the skin of white ox if the client is *bṛāhmaṇa*, lion or ox if the client is *kṣātrya*, and deer or goat if the client is *vaiśya*. Sitting over there he should lit the pious fire (in the altar) with the woods of *palāśa*, *ingudi*, *udumbara* or *madhūka*, spread all around *kūśa*, decorate it, and strew *lājā* (parched paddy) and fragrant white flowers. Now he should place near the altar the sacred water, treated with *mantras* (sacred words) and *ghṛta* for oblation and also the horse and other articles of decoration of the colour desired for the child.

Now the lady anxious to have the desired child, placing the *bṛāhmaṇa* on the south direction of fire should sit alongwith her husband on the west side of fire and follow the instructions of the priest. The priest should start the *putresṣi yajña* for fulfilment of the desires of the lady by indicating or characterizing *prajāpā* to the *yoni* (vagina) of the woman and reciting "visṇuryoni" etc. hymn. Now he should place the *carni* (oblation prepared with rice, barley etc. mixed with milk and *ghṛta* etc.) in saucapan, mix it with *ghṛta*

already treated with *mantras* and put thrice in oblation fire by the method indicated in *vedas* (the *vedas* according to ones own belief), and then handover the water-pot already sanctified with *mantras* to the woman and advise her to use the water of this pot wherever needed. After completion of this *vajña* the lady keeping fire towards her right side, lifting her right leg first should go round (the fire) alongwith her husband. After having benediction or pronouncement of the word "swasti" from *brāhmanas*, the *ghṛta* left over after sacrifice should be taken first by the husband then wife without leaving it. In this way they should have coition for eight nights. They will produce the child of the type of which cloths etc. have been used by them.

The procedure of *putresṣi vajña* given by Kāśyapa is slightly different. He says that now the priest should start *putresṣi vajña*. For oblation he should prepare material (*varu*) in eight bowls with the prepared meat, cooked rice, drugs capable of suppressing the *vāta*, a type of barley cake (*paraśāśa*) and rice. By this the couple attain better expression power and longevity. Now the hymn "ābrāhmanbrāhmaṇa" should be enchanted over the leftover substances after oblation performed for client and should be taken by the couple. White ox or horse or deer should be offered to physician not participating in the ceremony of preparing the pure sacred fire. They should perform the oblation daily in the fire kept in (altar of) the house and eat daily left over material after oblation properly enchanting the same *mantras*. Now the husband making the wife lie down on a soft comfortable bed, should take *lakṣmarā* (a drug), mix it with water, recite hundred times the hymn "somaḥ pavana" and "sāvitrī mantras", and give its inhalation to her reciting "apodevīrūpasrja" *mantras*. Reciting name of "vāmadevya" in low tone, keeping the wife on his right side the husband should go above the wife from left side and gradually act (do coition) for achievement of conception. After excretion of *bija* (semen), the wife retaining the same should separate herself, lateron irrigate (both of them their external genital organs) with cold water. After this (the woman) should avoid working near fire, hot sun, excessive labour, exercise and grief.

(ऊ) गौर वर्ण एवं ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए कर्तव्य (The methods to get fair complexioned and energetic son)

सा चेदेवमाशासीत-बृहत्तमवदातं हयक्षमोजस्विनं शुचिं सत्त्वसंपन्नं पुनश्चैवमिति, शुद्धस्नानात् प्रभृत्यै मथ्यमवदातयवानां मधुसर्पिर्भ्यां संसृज्य श्वेताया गोः सरूपवत्सायाः पयसाऽऽलोडय राजते कांशे वा पात्रे काले काले स्नाहं सततं प्रयच्छेत् पानाय । प्रातश्च शालियवात्रविकारान् दधिमधुसर्पिर्भिः पयोभिर्वा संसृज्य भुञ्जीत, तथा सायमवदातशरणशयनासनपानवसनभूषणा च स्यात् । सायं प्रातश्च शाश्वच्छेवतं महान्तं वृषभमाजनेयं वा हरिचन्दनाङ्गदं पश्येत् । सौम्याभिर्क्षेत्रां कथाभिर्मनोनुकूलाभिरुपासीत । सौम्याकृतिकचनोपचारच्छेष्टं स्त्रीपुरुषानितरानपि चेन्द्रियार्थानवदातान् पश्येत् । सहचर्यक्षेत्रां प्रियहिताभ्यां सततमुपचर्युस्तथा भर्ता । न च मिश्रीभावमापद्येयतामिति । अनेन विधिना सप्तरात्रं स्थित्वाऽष्टमेऽह्न्यालुब्धाद्भिः सशिरस्कं सह भर्ता अहतानि वस्त्राण्याच्छादयेदवदातानि, अचदाताश्च स्त्रजो भूषणानि च विभूयात् ॥ १॥ (च० सं० शा० ८/९)

सा चेदिच्छेद् गौरमोजस्विनं शुचिमायुष्यन्तं पुत्रं जनयेयमिति, तस्या एवं शुद्धस्नानात् प्रभृति शुक्लत्वयवसूनां मधुघृताभ्यां श्वेतायाः श्वेतपुंवत्साया गोःक्षीरेण मंसृज्य मथ्यं राजते पात्रे कांशे वा सदा पाययेत् । शालिगौरयवक्षीरदधिघृतप्रायं च काले मात्रया अश्रियात्, पुष्याभरणवाससि च शुक्लानि विभूयात्, सायं प्रातश्च श्वेतमश्वं वृषभं वा पश्येत्, सौम्यहिताभ्यामश्रिभासीत, अनुकूलपरिवारा च स्याद्विष्टमप्यत्र जनयति ॥

(का० सं० शा० ५/९)

यदि स्त्री चाहती है कि मेरा पुत्र विज्ञान एवं पुष्ट शरीर, गौर वर्ण, सिंह सदृश (पराक्रमी), ओजस्वी, पवित्र, सात्विक मन वाला हो तो उसे स्नान कर शुद्ध होने के पश्चात् (आर्तव-छाव के चौथे दिन) श्वेत यव के मथ्य (सत्तु) को मधु एवं सर्पि के साथ मिलाकर, श्वेत वर्ण एवं श्वेत वत्सा गौ के दूध में आलोडन कर चाँदी या काँसे के पात्र में रखकर, समय समय पर (प्रातः एवं सायं) एक सप्ताह तक पीने को दें । वह प्रातःकाल शालि (विशिष्ट धान्य) एवं यव से बने विभिन्न पदार्थों को दधि, मधु, घृत या दुग्ध के साथ मिलाकर खाये तथा सायंकाल श्वेत वर्ण के ही शरण (गृह), शयन (विस्तर), आसन (बैठने का स्थान), पान (खान, पान), वस्त्र एवं आभूषणों का प्रयोग करे । प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल श्वेत वर्ण के बृहत् वृषभ, अश्व, चन्दन एवं अंगद (विशिष्ट आभूषण) को देखे। उस स्त्री को मनोनुकूल एवं सौम्य कथाएँ सुनाये । सौम्य आकृति, वचन, उपचार (व्यवहार) एवं चेष्टा (इच्छाएँ) वाले स्त्री-पुरुषों को तथा अन्य इन्द्रियों की इच्छा वाले श्वेत पदार्थों को ही देखे (घ्राण इन्द्रियार्थ श्वेत पुष्प, दर्शन एवं श्रवण इन्द्रियार्थ श्वेत वाद्य यन्त्र आदि) । उस स्त्री के साथ उसको सहेलियाँ तथा पति सतत प्रिय एवं हितकर उपचार करें । इस काल में संभोग न करे । इस प्रकार सतत रात्रि व्यतीत हो जाने पर, आठवें दिन पति के साथ जल से शिर से स्नान कर, श्वेत एवं तूलन वस्त्र धारण कर, श्वेत माला एवं आभूषण धारण करे । (पश्चात् पूर्ववर्णित पुत्रेष्टि यज्ञ करें) ।

महर्षि कश्यप ने भी उपर्युक्त विधि को ही केवल शब्द-भेद से एवं संक्षेप में वर्णन किया है कि यदि स्त्री गौर वर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घायु पुत्र को जन्म देने की आकांक्षा रखती है तो उसे स्नान के पश्चात् श्वेत यव के मथ्य को मधु एवं घृत के साथ मिलाकर श्वेतवर्ण-वत्सा एवं श्वेतवर्णा गौ के दुग्ध में मिलाकर, चाँदी या काँसे के पात्र में सदा पीने को दें । मात्रानुसार शालि, श्वेत यव, दुग्ध, दधि एवं घृत समय पर भोजन के लिए दें । पुष्प, आभरण एवं वस्त्र श्वेत ही प्रयोग करें । श्वेत वृषभ एवं अश्व को देखे । उसे सौम्य, हित एवं प्रिय कथाएँ सुनाएँ तथा उसके पास उसके अनुकूल परिवार के लोग ही रहें, इस भाँति वह वांछित पुत्र को जन्म देती है ।

महर्षि भेल ने गौर वर्ण, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के लिए उपायों का वर्णन करते हुए लिखा है, कि स्त्री सात रात्रि तक यव का ओदन सर्पि से युक्त कर खाए, दौहद में श्वेत एवं सुन्दर वस्त्र वाली, श्वेत गौ के क्षीर में बनाई हुई पायस का भोजन करे, श्वेत वस्त्र धारण करे, सभी प्रकार के कार्य श्वेत संस्कृत करे, श्वेत वृषभ का दर्शन करे तो गौरवर्ण के पुत्र को जन्म देगी । महर्षि शौनक कहते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि इससे पैल्य बाधा उत्पन्न होगी । महर्षि अत्रेय ने कहा क्या आबाधक होगा ? पिंगल अवयव वाला व्यक्ति आयुष्मान एवं नीरोग होता है ।

Carak says that if the woman desires to have a son of tall, robust personality, fair complexion, resembling the lion (in courage), energetic, chaste, endowed with the qualities

१. साच्चेव(चेदा)कांक्षे(क्षे)द्वा(दी)(हि)(र्वा)कि(युः) शिवावदातपुत्रं जनय(ये)(यमिति) श्वानाम(मो)दनं सर्पिस्संयुक्तं सप्तरात्रमनुपहितं भुञ्जीत । ततो दौहदे श्वेताया गोः सरूप वत्साया पयसि पायसं पाचयित्वा तदेवास्त्री(स्त्री)यात् । शुक्ले च वासखः(सी)परि(द)भ्या(ध्या)त् । सर्वक्षेत्रं चास्याः संस्कृतं विमानं कारयेत् । (श्वेत) वृषभमव(या)स्या दर्शयेदवमवदातं पुत्रं जनयेत् ॥ ३॥

नेत्याह शौनकः । पैङ्गल्यं वा ततोयेत्यात्रेय उवाच किं स्यादाबाधकः, पिङ्गलावयवा आयुष्मन्तो नीरोगाश्च भवन्तीति ॥ ४॥ (श्रे० सं० शा० ८/३,४)

of goodness (*sānwika*), then after getting purified and having taken bath (purification due to cessation of menstrual flow on 4th day of period), she should be given the flour of parched white barley with honey and *ghṛta*, churned with milk of white cow having white calf with the utensil of silver or bronze timely (morning and evening) for seven days. In the morning she should take the edibles prepared with *śālī* (a type of rice) and barley with curd, honey, *ghṛta* or milk and in the evening should live in white coloured abode and use all the things like bed, cushion, edibles, drinks, clothe and ornaments etc. of white colour. Daily in the morning and evening she should look at white ox, white horse, sandal wood and *aṅgada* (specific ornament used in upper arm near elbow joint). She should be entertained with favourite and pleasing stories. She should look at men and women of charming personality, having pleasant words, gentle behaviour, good conduct and use other white objects desired by her sense organs (white flowers for olfactory sense, white instruments for auditory sense etc). Husband and other female companions should always do pleasant and gentle behaviour with her. She should not indulge in coition during this period. Living like this for seven nights, on eighth day she should take full bath (from head to toe) along with her husband, wear white and new garments, garland and ornaments, (this should, follow the *putreṣṭi yajña* described earlier).

Almost similar views have been expressed by Kāśyapa and Bhela.

(ए) श्याम आदि वर्ण के पुत्र की इच्छा होने पर स्त्री के लिए कर्तव्य (The procedures to get dark complexioned red-eyed son)

या तु स्त्री श्यामं लोहिताक्षं व्यूढोरस्कं महाबाहुं च पुत्रमाशासीत, या वा कृष्णं कृष्णामृदुदीर्घकेशं शुक्लाक्षं शुक्लदन्तं तेजस्विनामवन्तम्; एष एवानयोपि होमविधिः । किन्तु परबर्हो वर्णवर्जं स्यात् । पुत्रवर्णानुरूपस्तु यथाशीर्षिक तयोः परिबर्होऽन्यः कार्यः स्यात् ॥ (च० सं० शा० ८/१२)

या तु श्यामं लोहिताक्षं व्यूढोरस्कं पुत्रमिच्छेत् कृष्णं वा तत्र तादृगुपचारो भोजनवसनकुसुमालङ्काराणां, तादृग्देशानुचिन्तनं चेति । यवागूं तु कन्याधीनीभ्यो दद्यात्; क्षीरिदकतिलसिद्धास्तु वर्णयोः । गौरश्यामकृष्णोभ्योऽन्ये वर्णा निदिताः ॥ (का० सं० शा० ५/१९)

यदि स्त्री श्याम वर्ण, रक्ताक्ष, विस्तृत एवं उन्नत उर तथा लम्बी बाहु वाले पुत्र की आकांक्षा रखती है या कृष्ण वर्ण, काले, मृदु तथा लम्बे केश, क्षेत आखें एवं दन्त वाले तथा तेजस्वी एवं जितेन्द्रिय पुत्र की इच्छा रखती है, तो उसके लिए भी (पूर्ववर्णित) यही हवन-विधि है, केवल परिबर्ह (गृह, शयन, आसन, पुष्प, वस्त्र आदि) के वर्ण में परिवर्तन होता है । वांछित पुत्र के वर्ण के अनुरूप ही परिबर्ह का प्रयोग एवं अन्य कार्य (दर्शनादि) करना चाहिए ।

महर्षि कारस्य ने भी यही लिखा है कि यदि स्त्री श्याम वर्ण, रक्ताक्ष, विस्तृत एवं उन्नत उर वाले अथवा कृष्ण वर्ण के पुत्र की आकांक्षा रखती है, तो उसी प्रकार के उपचार, भोजन, वस्त्र, पुष्प एवं अलंकारों का प्रयोग करे, उसी प्रकार के (पुरुषों के) देश का चिन्तन करे । कन्याधीनी स्त्री को यवागू का भोजन देना चाहिए । सिद्ध किये हुए क्षीरोदक एवं तिल वर्ण (शारीरिक) के वृद्धिकारक होते हैं । गौर, श्याम एवं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण निन्दित माने गये हैं ।

महर्षि भेल ने लिखा है कि यदि स्त्री श्याम वर्ण के एवं लोहिताक्ष पुत्र को उत्पन्न करने की इच्छा करती है, तो वह 'द्वितीय मासे से शब्दं कारयेत्' तक का अर्थ स्पष्ट नहीं है अतः यहाँ नहीं दिया गया) लोहित वर्ण के कुकुट के रक्त को रक्तशाली के साथ मिला कर, सात रात्रि तक (तथा) दौहद में भोजन करे । ताम्र वर्ण के वल्ल धारण करे । इसके

शयन एवं आसन (के वस्त्र या स्थान) ताम्र वर्ण के हों । रक्त वर्ण के वृषभ एवं अज का दर्शन करे । इससे श्याम वर्ण, लोहिताक्ष पुत्र को जन्म देगी ।

For the woman desirous of having a dark complexioned, red eyed son possessing broad chest and long arms; or a son having dark complexion, long-soft-black hair, white eyes and teeth and who is brilliant, possesses good control over his sensory and motor organs, the procedure of oblation is same, the only difference being in the colours of surroundings (abode, bed, cushion, flowers, garments etc.). The colours of surroundings and other articles to be used should be identical with the wanted complexion for the child.

Kāśyapa corroborating the above statement says further that the woman desirous of having female child should use gruel. Medicated milk, water and *tīla* (sesamum seed) are beneficial for complexion. Besides fair (*gaura*), dark (*śyāma*) and black (*kṛṣṇa*) other complexions are unwanted.

Bhela opines that the woman desiring to have red eyed and dark complexioned son should consume the blood of red cock mixed with red *śālī* for seven days and also during *dhārḍa*. She should use the garments, bed and cushion of copper colour, look at the red ox and goat, thus she will deliver red eyed dark complexioned son.

(ऐ) स्त्री की मानसिक अवस्था का गर्भ में प्रभाव (Effect of psychology of the woman on the fetus)

या या च यथाविधं पुत्रमाशासीत तस्यास्तस्यास्तां तां पुत्राशिषमनुनिशम्य तांस्ताङ्गनपदामनसाऽनुपरिक्रामयेत् । ततो या या येषां जन्मपदानां मनुष्याणामनुरूपं पुत्रमाशासीत सा सः तेषां जन्मपदानां मनुष्याणामाहार-विहारोपचारपरिच्छदाननुविधत्सेति वाच्या स्यात् । इत्येतत् सर्वं पुत्राशिषां समृद्धिकारं कर्म व्याख्यातं भवति ।

(च० सं० शा० ८/१४)

आहाराचारवेष्टाभिर्यादृशीभिः समन्वितौ । स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः ॥

(सु० सं० शा० २/४६ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/६२)

यादृशं च पुत्रमाशासीत तद्रूपवर्णचरितान् जन्मपदाननुचिन्तयेति स्त्री वाच्या । तज्जनपदाहारविहारोपचार-परिच्छदांश्चानुविधीति ॥ (अ० सं० शा० १/५३)

इच्छेतां यादृशं पुत्रं तद्रूपचरितांश्च तौ । चिन्तयेतां जन्मपदास्तदाचारपरिच्छदौ ॥

(अ० ह० शा० १/३१)

जो स्त्री जिस जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा रखती हो, उसकी उस पुत्रेच्छा को सुनकर (वैद्य) उन उन भाँति के देशों को मन से ध्यान करने को कहे । वह स्त्री जिस-जिस देशवासी मनुष्यों के अनुरूप पुत्र की इच्छा रखती हो, उन उन देशवासी मनुष्यों के आहार, विहार, उपचार (व्यवहार) एवं परिच्छद (वल्ल आदि) का उन्हीं की विधि एवं वाणी के अनुसार प्रयोग करे । इस प्रकार सभी पुत्र की इच्छाओं के समृद्धिकार कर्मों की व्याख्या हो गई ।

१. सार्वेदेवमाशस(सी)त श्यामं लोहिताक्षं पुत्रं जनयिदे(तास्मि) यावत्, द्वितीये मासे पुंषं पश्येत् । यमिति येमावचवानां (यमितमासमनुचं वा) शब्दं कारयेत् । लोहितकुकुटकं सप्तरात्रं रक्तशाल्यमनुपहतं भुज्जीनं(त) दौहदि(दे), सा ताभ्रेण च वाससा परिदध्यात्, ताम्रे वास्याः शयनासने दद्यात्, रक्तवृषभमदं(जं) वास्या दशयेत् । एवं श्यामं लोहिताक्षं पुत्रं जनयति ॥ (धे० सं० शा० ८/४६)

महर्षि चरक ने अन्ध्र स्पष्ट कर दिया है कि गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस प्राणी की ओर आकृष्ट होता है वही उस प्राणी के सदृश मन्तान उत्पन्न करती है।^१ सूत्रस्थान में गर्भधारण के लिये मन की प्रसन्नता होना सर्वश्रेष्ठ माना है।^२

महर्षि सुश्रुत के मतानुसार स्त्री एवं पुरुष जिस प्रकार के आहार, आचार एवं चेष्टा में युक्त हो कर संभोग करते हैं उसी भाँति का पुत्र भी उत्पन्न करते हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने उपायुक्त मत का ही अनुपोदन करते हुए संक्षेप में लिखा है कि स्त्री जिस प्रकार के पुत्र की कामना करती है उसी प्रकार के रूप, वर्ण एवं चरित्र (आचरण) वाले देशों का मन से चिंतन करे तथा उसी देशानुसार आहार, विहार, उपवास एवं परिच्छद का उसी विधि से प्रयोग करे। महर्षि चरक-संज्ञा इन्होंने भी गर्भधारण के लिए मन की प्रसन्नता को सर्वश्रेष्ठ माना है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी उपायुक्त मत का सूत्र रूप में वर्णन किया है, कि स्त्री जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा करे, उसी प्रकार के रूप एवं चरित्र वाले देशों का चिंतन करे एवं उन्हीं की भाँति आचार तथा परिच्छद का प्रयोग करे। परिच्छद से टीकाकार अरुणदत्त ने मनुष्य, गौ, अश्व, धन, वस्त्र, अलङ्कार, रत्न, रथ, आयुध, गृह, उद्यान, वीणा, पणव (ढोल), गायन, शय्या एवं न्याय आदि का ग्रहण किया है, अर्थात् स्त्री मानसिक रूप से तथा वातावरण की दृष्टि से उसी देश की परिस्थिति में रहे, जिस देश के वर्ण, संस्थान, प्रमाण एवं आकृति वाली सन्तान की इच्छा करती है या श्रद्धा, श्रुत, सत्य, अर्जव, मानवता, ज्ञान, दया, तक्षिण्य आदि के अनुसार जिस प्रकार के स्वभाव की संतान चाहती है उस प्रकार का आचरण करे।^३

The physician after eliciting the desire of woman about the type of child, should advise her to always think of those type of countries. The woman desirous of having a child resembling to the persons of any specific country should use diet, mode of life, behaviour and garments identical to the persons of that very country and also by the same methods as practised by them.

The born child emulates the characters of creature who comes in thoughts of the woman during coitus / fertilization. For achievement of conception happy mood is essential. Sūśruta opines that what-so-ever type of diet, behaviour and conduct is followed by the couple at the time of coitus, born child possesses similar characters.

Vāgbhata I and II agree with the above sayings. Arunadatta elaborates that with the word surroundings, the persons, cow, horses, money, grain, clothes, ornaments, jewels, chariot, weapons, abode, garden, lyre, drum, songs, bed, bed-sheets etc. all the things coming in contact should be taken or in other words environment and psychology of woman should be identical to the persons of the country, whose complexion, size, features etc. she wishes to be emulated by her child. She should practice similar behaviour in terms of faith, hearing, truth, honesty or straightforwardness, humanity, charity, compassion or mercy and politeness or courtesy as she wishes to be the nature of her child.

१. गर्भोपपत्तौ तु मनः स्थिता ये कर्तुं वृत्तेस्तस्यैव प्रसूते॥ (चं सं० शां० २/२५)

२. सौमन्त्र्यं गर्भधारणानां। (चं सं० सू० २५/३० एवं अं सं० सू० १३/३)

३. रूपं वर्णसंज्ञानुसमाधकृत्यादि। तथा चरितं-श्रद्धाश्रुतसत्यार्जवमनुशंसदात्तदक्षिण्यस्वभावदि। परिच्छदीयानुजाबाध-धनमान्यस्वस्त्रालङ्काररत्नरथायुधगृहोद्यानवीणापणवगायनसंख्यास्तथादिः। (अं सं० शां० १/३१ को अरुण० टी०)

(ओ) पुत्रीय विधि के पालन से लाभ (Benefits of specific mode of life or putrīyavidhi)

एवं जाता रूपवन्तः मन्त्रवन्तीश्चायुधः। भवन्त्युपायस्य मोकारः ससुत्राः पुत्रिणो (पो)हिताः।

(सु० सं० शां० २/३४)

देवताब्रह्मणपराः शौचाचारहिते स्ताः। महागुणान् प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निर्गुणान्॥

(सु० सं० शां० ३/३५)

जातश्चैवं रूपवन्तौ महासत्त्वाश्चायुधः। ऋणान्मोचयितारः स्युः सुपुत्राः पुत्रिणां मताः॥७०॥

देवताचारशौचादिरता सूते महागुणम्। धावत्येवं चाचरितं प्राग्जन्माप्यस्योगतः॥७१॥

(अं सं० शां० १/७० व ७१)

इस प्रकार से (रजःश्लेष्माचर्या-पालन, पुत्रीयविधि-पालन आदि से) उत्पन्न पुत्र रूपवान्, सत्यवान्, चिरायु, माता-पिता के ऋण का मोचन करने वाले ससुत्र होते हैं।

देवता एवं ब्राह्मण परायण, गृह और हितकर आहार में रता (पति, पत्नी या व्यक्ति) महागुणवान् पुत्र को एवं विपरीत (कर्मकर्ता) गुण-विहीन पुत्र को जन्म देते हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी महर्षि सुश्रुत के सदृश ही रूपवान् आदि पुत्र की उत्पत्ति का अक्षरशः समर्थन किया है एवं देवता तथा ब्राह्मण के स्थान पर केवल देवपरायणता का ही वर्णन किया है, साथ ही इन्होंने महागुणी पुत्रोत्पत्ति के लिये पूर्वजन्म-कर्म के फल को भी कारण-स्वरूप माना है।

By observing this specific mode of life (during menstruation and putrīya yajña etc. described in preceding pages) the born children are handsome, endowed with goodness, have long life, repay the debts of parents and are excellent; the couple respecting or worshipping deities and *brāhmanas*, observing chastity and using beneficial dietetics give birth to the child possessing all good qualities, while having opposite deeds deliver the child devoid of good qualities.

Vāgbhata I corroborating the views of Sūśruta says further that besides specific mode of life the deeds of previous life also influence qualities of the child.

विमर्श (Comments)

पूर्वपुरुषों में वर्णित गर्भ-प्राप्ति के लिए कर्तव्यों (अ से ऐ तक) का आधुनिक विज्ञान-दृष्ट्या स्पष्टीकरण कठिन है, फिर भी यह हो सकता है कि विशिष्ट खान, पान, आचार, विहार आदि का कुछ प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता हो। ब्रह्मचर्य एवं पौष्टिक आहार-प्रयोग तथा पूर्वकर्म में शोधनार्थि के प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ा हुआ प्रभाव प्रजोत्पन्न-समर्था को प्रभावित कर सकता है। यज्ञ-विधि, मन्त्र-प्रयोग आदि उस समय की सामाजिक व्यवस्था के परिचायक हैं। स्त्री एवं पुरुष की मानसिक स्थिति का गर्भोत्पन्न में प्रभाव आधुनिक विज्ञान भी मानता है। यह संभव है कि लगातार एक ही वर्ण का प्रयोग होने से गर्भ के वर्ण आदि में भी कुछ प्रभाव पड़े, जो एक अनुसंधान का विषय है। उस काल में संभोग केवल प्रजोत्पन्न के लिये ही वर्णित है, वासना-पूर्वक के लिये नहीं, जो कि नैसर्गिक परिवार-नियोजन की विधि का कार्य करता होगा, साथ ही यह उस काल के मनुष्यों की मानसिक दृढ़ता का भी परिचायक है।

Though it is difficult to explain the entire subject discussed under a to ai, however, hypothetically it is just possible that specific environment might influence characters of the child to certain extent. Celebacy, specific dietetics and cleansing measures might influence

the reproductive capabilities. *Yajña* and *mantras* reflect the social customs and belief. Psychology of couple might influence the mental build up of the child. Continuous use of one particular colour may influence to certain extent complexion of the child, which is a subject of research. The coition was exclusively for reproduction, not for carnal pleasure. this shows the strong will-power of the persons and also a method of limiting the family.

□

अध्याय ४

CHAPTER IV

गर्भ-विज्ञानीय अध्याय

(EMBRYOLOGY)

गर्भावकान्ति, गर्भ-वृद्धि एवं गर्भाङ्ग-विकृति तथा पुंसवन कर्म आदि (*Descent of embryo, its development, teratologic abnormalities and punsavana karma etc.*)

गर्भ की परिभाषा (*Definition of garbha or embryo*)

... स गर्भाशयमनुप्रविश्य शुक्रशोणितान्ध्रं संयोगेनेत्य गर्भत्वेन जनयत्यात्मनाऽऽत्मानम्, आत्मसंज्ञा हि गर्भे ।
..... यथा-सत्तामेव शुक्रशोणितजीवानां प्राक् संयोगादुत्पत्तत्वं न भवति, तच्च संयोगाद्भवति ॥

(च० सं० शा० ३/८)

शक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति ॥ (च० सं० शा० ४/५)
शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसंमुख्यं गर्भ इत्युच्यते ॥ (सु० सं० शा० ५/३)

वह जीव गर्भाशय में प्रवेश कर शुक्र एवं शोणित से संयुक्त हो, गर्भत्व को प्राप्त हो, स्वयं (आत्मा) को उत्पन्न करता है एवं गर्भ में आत्मा की संज्ञा हो रखता है । शुक्र, शोणित एवं जीव के संयोग के पूर्व उसे गर्भ नहीं कह सकते । इन सबके संयोग के बाद ही इसकी गर्भ संज्ञा होती है ।

शुक्र, शोणित एवं जीव के कुक्षि (गर्भाशय) के अन्तर्गत संयोग को गर्भ की संज्ञा दी जाती है ।

महर्षि सुश्रुत के मतानुसार गर्भाशय में स्थित, आत्मा, प्रकृति एवं विकारों से सम्मुखित शुक्र तथा शोणित को गर्भ कहा जाता है; एवं बढ़ता हुआ जब वह हस्त, पाद, जिह्वा, घ्राण, कर्ण एवं नितम्ब आदि अङ्गों से युक्त हो जाता है तब शरीर की संज्ञा प्राप्त करता है^१ ।

महर्षि वाग्भट ने भी कुक्षि या गर्भाशयान्तर्गत शुक्र एवं शोणित के साथ आत्मा या जीव तथा प्रकृति एवं अन्य विकारों के सम्मिश्रण से ही गर्भ की उत्पत्ति मानी है^२ ।

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत के विचारों का अनुमोदन किया है^३ ।

महर्षि हारीत ने देह को पञ्च तत्त्व, पञ्चैन्द्रिय, सप्त धातु तथा दश वायु से निर्मित बताया है, तथा वीर्य एवं रज से उत्पन्न शरीर को जीव, मन एवं आकाश से युक्त, त्रिगुणात्मक माना है, एवं लिखा है कि शुक्र एवं शोणित से निर्मित

१. एवं विवर्धितः स यदा हस्तपादजिह्वाघ्राणकर्णनितम्बादिभिरङ्गैरुपेतस्तदा शरीरमिति संज्ञां लभते। (सु० सं० शा० ५/३)

२. अ० सं० शा० २/३, अ० ह० शा० १/१ (पृष्ठ १०६)

३. गर्भाशयगतं शुक्रमन्तर्वं जीवसंज्ञकः। प्रकृतिः सविकारा च तत्सर्वं गर्भसंज्ञकम्॥
कालेन विवर्धितो गर्भो यद्यङ्गोपाङ्गसंयुतः। भवेत्तदा स मुनिभिः शरीरीति निगद्यते॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/६३, ६४)

गर्ह शरीर दोष का पात्र अर्थात् दोषों से दूषित होता है। हे श्रेष्ठ वैद्य! इस शरीर को पञ्चमहाभूतों से युक्त जानो।^१ महर्षि शार्ङ्गपर ने भी शुद्ध शुक्र एवं शोणित के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन किया है, यही गर्भ पैदा हो जाने पर "बाल" सन्तान से कहा जाता है।^२

The union of *śukra* (sperm), *ārtava* (ovum) and *ātmā* or *jīva* inside the *kūḍḍī* (uterus) is known as *grābhā* (zygote, embryo or fetus). Besides *ātmā*, the association of *prāṇā* and *vīkṛtā* is also essential; after development of arms, legs, tongue, nose, ears and hips etc. body-parts, it is termed *śarīra*. Mātrā defines that the body is composed of five *tanū*as, five *indriyas*, seven *dhātus* and ten *vāyus*. The body formed with combination of *prāṇa* (sperms) and *vajā* (ovum) is *triguṇāmāka* due to influence of *jīva*, *māna* and *ākāśa*. This *prāṇabhautika* body is vulnerable for being vitiated by *doshas*. Sāṅgadhara clarifies that this *very* fetus after its delivery is termed as *bāla* (child).

गर्भावकांति (Process of descent of various components in embryo)

पुरुषस्यानुपहततसः स्त्रियाश्चापदुष्टोनिशोणितगर्भाशयाया यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले, यदाचानयोस्तथायुक्ते संसर्गे शुक्रशोणितसंसर्गमन्तर्गर्भाशयात् जीवोऽवकाशमिति सत्त्वसंप्रयोगात्तादा गर्भोऽभिनिर्वर्तते, स सात्त्व्यरसोपयोगादयोगोऽभिभवति सम्युत्पादश्लोषवर्धमाणा, ततः प्राप्तकालः सर्वोद्भयोपपन्नः परिपूर्णशरीरो बलवर्णसत्त्वसंहनन-संबद्धपेतः सुखेन जायते समुद्रवादेयां भावना-मानुजश्चायं गर्भः पितृजश्चात्मजश्च सात्त्व्यजश्च रसजश्च, अस्ति च खलु सत्त्वमौपपादुकिमिति होवाच भगवानात्रेयः ॥ (च० सं० शा० ३/३)

तथा सह तथाभूतया यदा पुमानव्यापन्नबीजो मिश्रीभावं गच्छति, तदा तस्य हर्षोदीतिः परः शरीरधात्मा शुकभूतोऽङ्गादङ्गात् संभवति। स तथा हर्षभूतेनाननोदीरितश्चाभिहितश्च बीजरूपो धातुः पुरुषशरीरादीभिर्निरूप्योचितेन पथा गर्भाशयमनुप्रविश्यात्वेनाभिसंसर्गमिति ॥ (च० सं० शा० ४/७)

तत्र स्त्रीपुंसयोः संयोगो तेजः शरीराद् वायुरदीरयति, ततस्तेजोऽनिलसिन्धुताच्छुक्रं च्युतं योनिर्मभिप्रतिपद्यते संसृज्यते चार्तवेना ततोऽग्निषोमसंयोगात् संसृज्यमानो गर्भाशयमनुप्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञो वेदरिता स्मष्टा धाता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्मष्टा गन्ता साक्षी धाता वक्ता यः कोऽसावित्र्येयमादिभिः पर्यायवाचकेनाभिभूतमधीयते दैवसंयोगादक्षयोऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं सत्त्वजस्तमोभिर्दैवासुरपरैश्च भावैर्वायुनाऽग्निप्रयेयमाणा गर्भाशयमनुप्रविश्यावतिष्ठते ॥ (सु० सं० शा० ३/४)

गते पुराणो रजसि नवेऽवस्थिते शुद्धे गर्भस्याशये मार्गे च बीजात्मना शुक्रमविकृतमविकृतेन वायुना प्रेरितमन्यैश्च महाभूतैरनुगतमार्तवेनाभिमुर्च्छितमन्वक्षमेव रागादिक्लेशवशानुवर्तिना स्वकर्मचोदितेन मनोवचेन जीवेनाभिसंसृष्टं गर्भाशयमुपययाति। (अ० सं० शा० २/३)

शुद्धे शुक्रार्तवे सत्त्वः स्वकर्मरक्षणेनोदितः। गर्भः सम्पद्यते युक्तिवशादतिरिचाराणो ॥ १ ॥
तेजो यथाऽर्कशमीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम्। नेत्र्यनं दृश्यते गच्छत्, सत्त्वो गर्भाशयं तथा ॥ ३ ॥
(अ० ह० शा० १/१ व ३)

१. पञ्चभूतान्तकं देहं पञ्चोद्भवसमायुतम्। सप्तधागुणोभेन दशजातान्तिनिकं विदुः ॥ १ ॥

जीवो मनस्वकाशस्तथैव त्रिगुणान्तकः। शुक्रशोणितसम्भूतं शरीरं दोषभाजनम्।

पञ्चभूतमयं वैतद्विशेषं भिषजां वरः ॥ २ ॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १/१ व २)

२. कामान्मिथुनसंयोगे शुद्धशोणितशुक्रजः। गर्भः सञ्जायते नार्थाः स जातो बाल उच्यते ॥ (शा० सं० पूर्व० ६/११)

जीवन्तु खलु भो सर्वगतत्वादीश्वराणामभिन्तः पूर्वशरीराव्यावकाशमिति परशरीरं चोपकामिति युगापत्, न कदाचिदपि बीजशोणितवाच्याकाशदिमनोबुद्धिभिर्विकृतपूर्वः, सर्वगतत्वाच्च न कस्याश्चिद्योनौ नोपपद्यते स्वकर्मफलानुभावदिति ॥ (का० सं० शा० ३/३)

जब अट्टप या शुद्ध शुक्र बाला पुरुष, शुद्ध योनि, गर्भाशय एवं शोणित वाला स्त्री के साथ ऋतुकाल में सम्भोग करता है, एवं इस प्रकार का संसर्ग होने पर जब शुक्र एवं शोणित का गर्भाशय के अन्तर संयोग होता है, तब क्रियाशील मन के साथ होने से जीवत्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है। वह गर्भ (गर्भिणी द्वारा) सात्त्व्य रसों के प्रयोग से एवं अन्य बलाएँ हुए उपचारों से (गर्भिणी-परिचर्या में वर्णित उपचारों से) उपवर्धित होता हुआ निरोग या स्वस्थ होकर बढ़ता है। इसके बाद प्राप्तकाल (प्रसवकाल) होने पर सर्वोद्भय युक्त हो, पूर्ण शरीरज्ञों को प्राप्त कर, बल, वर्ण, सत्त्व एवं संहनन से युक्त होकर, मातृज, पितृज, आत्मज, सात्त्व्यज एवं रसज आदि भावों से युक्त, मन के नित्य सम्बन्ध के साथ उत्पन्न होता है, ऐसा भावना अत्रिय ने कहा है।

लगभग इसी वर्णन की महर्षि चरक ने पुनरावृत्ति की है, कि जिस अनुपूर्व क्रम से कृषि (गर्भाशय) में गर्भ अवतरित होता है, उसकी व्याख्या करेंगे। ऋतुमती स्त्री के साथ जब शुद्ध बीज बाला पुरुष सम्भोग करता है तो हर्ष के कारण शरीर-धातु रूप शुक्र अंगों-अंगों से उत्पन्न होता है एवं उस हर्ष के ही कारण (धातुओं में) अधिष्ठित शुक्र-धातु निःसरित हो बीज-रूप में पुरुष के शरीर से निकल कर उचित पथ (योनि-मार्ग) के द्वारा गर्भाशय में प्रविष्ट होकर अर्तव के साथ मिश्रित होता है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि स्त्री-पुरुष संयोग के समय तेज (शरीर की ऊष्मा) वायु को उत्तेजित करता है,^३ तब तेज और वायु के संनिपात से क्षरित हुआ शुक्र, योनि को प्राप्त होकर अर्थात् गर्भाशय में पहुँच कर अर्तव से मिल जाता है, इस प्रकार अग्नि (अर्तव) और सोम (शुक्र) के संयोग से उत्पन्न गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है, तत्पश्चात् क्षेत्रज्ञ, वेदयिता, स्मष्टा, धाता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, स्मष्टा, गन्ता, साक्षी, धाता एवं वक्ता आदि पर्यायवाची नामों से जाना जाने वाला, अक्षय, अव्यय एवं अचिन्त्य होते हुए भी दैव के संयोग से भूत, सत्त्व, रज, तम, देव एवं असुर या अन्य भावों से युक्त, वायु के द्वारा प्रेरित हो (वह जीव) गर्भाशय में प्रविष्ट हो अवस्थान करता है।

अष्टांगसंग्रह-मतानुसार पुराण रज के समाप्त एवं नवीन रज के स्थित हो जाने तथा गर्भाशय एवं योनिमार्ग के शुद्ध हो जाने पर, अधिकृत शुक्र, बीज रूप में अधिकृत वायु के द्वारा प्रेरित हो, अन्य महाभूतों द्वारा अनुगत हो, अर्तव के साथ अभिमुर्च्छित होता है, तत्क्षण ही रागादि क्लेशों के वशीभूत, पूर्वजन्म के कर्मों से प्रेरित होकर मन के वेग के कारण जीव से मिश्रित हो (वह शुक्रार्तव) गर्भाशय में आता है।

अष्टांगहृदयकार ने भी शब्द-भेद से अष्टांगसंग्रह-सदृश ही वर्णन किया है कि स्वकर्म एवं क्लेश से प्रेरित सत्त्व शुद्ध शुक्र तथा अर्तव के संयोग में मिलकर गर्भ की उसी प्रकार सम्पादित करता है, जिस प्रकार युक्ति के वश से (मध्य, मन्थन एवं मन्थनकर्ता) अराणि से अग्नि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार स्फटिक मणि से इश्चन की ओर जाती हुई अग्नि एवं सूर्य से निकलती हुई किरणें दिखाई नहीं देती (केवल अग्नि एवं ताप या परिणाम ही दिखाई देता है), उसी प्रकार गर्भाशय में सत्त्व का प्रवेश दिखाई नहीं देता।

महर्षि कश्यप ने भी पूर्व वर्णित विचारों के सदृश ही पूर्वजन्म के महत्त्व को दर्शाते हुए लिखा है कि जीव सर्वगत

१. च० सं० शा० ४/७ (पृष्ठ ७५)

२. "शरीरधात्मात्मा" शब्द से कुछ विद्वानों ने शुक्र स्वरूप आत्मा लिखा है पर टीकाकार चक्रपाणि ने 'शरीरधात्मात्मा' 'शरीरधातुरूपः' लिखा है जो व्यादा युक्तिसंगत है।

३. उदीरयति उक्तं करोति (सु० सं० शा० ३/४ की इच्छण टीका)।

होने से ईश्वर के गुणों से युक्त, पूर्व शरीर का त्याग एवं फल (अगले) शरीर में प्रवेश एक साथ ही करता है। अतः इसका (इस जीव का) बीज (शुक्र), शोणित, वायु आदि पञ्चमहाभूत, मन एवं बुद्धि आदि से कभी भी वियोग नहीं होता (गर्भ इन सभी के संयोग से ही बनता है)। यह जीव सर्वगत होने से जिस किसी भी योनि में न जाकर पूर्वजन्म-कर्मफल के अनुसार ही योनि को प्राप्त करता है।

आचार्य भगविमित्र ने गर्भाविक्रान्ति के वर्णन में महर्षि सुश्रुत का ही अनुसरण किया है, साथ ही जीव के प्रवेश का वर्णन अष्टांगहृदय सदृश दिया है।^१

महर्षि हारीत ने शरीर-स्थित धातुओं को प्रधानता का वर्णन करते हुए लिखा है कि मैथुन से गर्भ की उत्पत्ति होती है। सर्व प्रथम धातु बल, धातु बल से सत्व, सत्व से रज, रज से काम उत्पन्न होता है तथा काम से संगम होता है। यद्यपि स्त्रियों में रज बिना योग या प्रयत्न के ही दृष्टिगोचर होता है पर बिना योग या प्रयत्न (संयोग) के फल अर्थात् गर्भ की स्थिति नहीं होती। अन्यत्र श्रियाँ के द्वारा किये गये इस प्रश्न “कि स्त्रियों में पुण्य (श्रुतलाभ) हो जाने पर वृश्चादि की तरह बिना संयोग के ही गर्भ क्यों नहीं होता?” के उत्तर में स्पष्टीकरण दिया है, कि वृक्षों में निश्चल शिव एवं व्यास शक्ति अर्थात् पुरुष एवं स्त्री गुण साथ ही प्रवृत्त होते हैं, परन्तु स्त्रियाँ केवल रजोमय होती हैं, बीज पुरुष की इन्द्रिय में रहता है, अतः संयोग से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है।^२

महर्षि भेल ने संश्लेष में लिखा है कि स्त्री की योनि में आये हुये शुक्र को वायु ग्रहण कर लेती है, जो शुद्ध अर्तव से मिलकर स्त्री को गर्भवती कर देता है।^३

महर्षि भेल ने पुनः श्व गर्भाविक्रान्ति का विस्तृत वर्णन करते हुये कहा है, कि ऋतुकाल में ही गर्भाधान होता है। जिस प्रकार भली भाँति निमित्त क्षेत्र में डाला हुआ बीज यदि ब्रीहि (धान) है तो धान्यत्व को, यव है तो यवत्व को प्राप्त होता है (अर्थात् बीज से पौधा उत्पन्न हो धान्य की उत्पत्ति करता है), उसी प्रकार अट्टुष्ट या स्वस्थ योनि में, ऋतुकाल में, इन्द्रिय (शिश्नेन्द्रिय) से त्वक (शुक्र या बीज) गर्भाशय में जाता है। यहाँ वह योनि के आवर्तों में ग्रहण किया जाता हुआ आगे

१. कामान्मिथुनसंयोगे शुद्धशोणित शुक्रजः। गर्भः सञ्जायते नायाः सञ्जातो बाल उच्यते ॥ २७॥
ऋतौ श्रोतुसंयोगे मकराव्यवहेगतः। मेढ्रयोन्मिषसंघर्षच्छरीरेष्वाऽनिलहृतः ॥ २८॥
पुंसः सर्वशरीरस्थं रेतो द्रावयतेऽथ तत्। वायुर्मेहनमार्गेण पातयत्यङ्गनाभो ॥ २९॥
तत् संश्लेष व्यानमुखं याति गर्भाशयं प्रति। तत्र शुक्रवदायतेनोतवेन युतं भवेत् ॥ ३०॥
शुक्रार्तवसमारसेषो यदैव खलु जायते। जीवस्तदैव विशति युक्तः शुक्रार्तवान्तरः ॥ ३३॥
सूर्याशोः सूर्यमणित उभयस्मरुतावध। वह्निः सञ्जायते जीवस्ताथा शुक्रार्तवमुत्प्रातः ॥ ३४॥
आत्माऽजोदिरन्तश्चाऽव्यक्तो वक्तुं न शक्यते। चिदानन्दैकरूपोऽयं मनसाऽपि न गम्यते ॥ ३५॥
एवं भूतोऽपि जातौ भगिनी वलवत्य। अविद्यास्वीकृते कर्मवशो गर्भं विशत्यसौ ॥ ३६॥
स एव वेता रसनो द्रष्टा घ्राता स्पर्शत्यसौ। श्रोता वक्ता च कर्ता च गन्ता रतौत्युज्जत्यसौ ॥ ३७॥ (भा० प्र० पूर्व ३)
२. तस्माच्च मैथुनास्तम्यजायते गर्भसंभवः ॥ ६॥
- आदौ धातुबलं तस्मात्सत्त्वं तस्माद्रजो विदुः। रजसा जायते कामः कामास्तुतसङ्गमः ॥ ७॥
दृश्यते च रजः स्त्रीणां बिना योगेन युक्तः ॥ १॥ दृश्यते न बिना योगाफलं स्त्रीणां तु युक्तः ॥ १०॥
(हा० सं० षष्ठस्थान १६, ७, ९, १०)

३. संयोगेन बिना प्राज्ञः। कथं गर्भो न जायते। संयोगेन बिना पुण्यं फलं वा न कथं भवेत् ॥ १॥
रस्यावराणश्च सर्वेषां शिवशक्तियमं विदुः ॥ १४॥ निश्चलोऽपि शिवो शेषो व्यावशक्तिर्महामते ॥ १५॥
स्त्रीणां रजोमयं रेतो बीजाढ्यामिन्द्रियं नरे। तस्मात्संयोगातः पुनः जायते गर्भसंभवः ॥ १६॥
(हा० सं० षष्ठस्थान १११, १४ से १६)

४. गृह्णीति वायुर्मुस्यो च योने शुक्रमुपागतः(न)। बिभर्ति गर्भि(धर्म)णी गर्भं शुद्धान्तसमन्वितम् ॥ (भे० सं० शां० ३६)

दौडता है या जाता है (योनि-गर्भाशय-डिम्बप्रणाली इस प्रकार शुक्राणु आगे जाते हैं)। तत्पश्चात् शुक्र एवं शोणित गर्भाशय में क्षीर सदृश अस्तिर रहते हैं (अर्थात् प्रारम्भ में शुक्र एवं शोणित द्रव के समान गर्भाशय एवं डिम्बप्रणाली में अस्तिर रूप में रहते हैं)। (इस शुक्र के) निषेक के पश्चात् (अर्तव के साथ) एकत्व को प्राप्त होकर, उदुम्बर-सदृश अनेकोत्पादक (बिना पुण्य के दृष्टिगोचर हुए ही उदुम्बर के फल की वृद्धि होती है, उसी भाँति बिना अंग-प्रत्यांग-विभागा के दृष्टिगोचर हुये ही शरीर के अनेकों अंगों के उत्पादक) शरीर की वृद्धि होती है।^४

There is some difference in the events described by various authors. Caraka says that when a man copulates with a *ritumati* woman (described earlier), then due to excitement and pleasure the *dhatu-rupa sukra* situated in various body parts is excreted. This excreted *sukra-dhatu* coming out of male's body, in the form of *bija* (seed or sperms) enters the uterus through proper passage (vagina) and gets mixed with *arava* or *sonia* (ovum). At this very time, due to association of *satwa* or *mana*, the *jivama* comes there in the *garbha* (zygote). Due to constant use of congenial diet by the pregnant woman, this *garbha* (fetus) grows normally and gets delivered at appropriate time with all *indriyas* (sensory and motor organs), complete body parts, *bala* (energy), *varna* (complexion), *satwa* (endurance) and *saripahana* (compactness) alongwith *matirja* (maternal), *pitirja* (paternal), *amaja*, *sampitirja* and *rasaja bhavvas* (physical and psychological components) having constant association of *mana*.

Susruta opines that *teja* or heat generated at the time of coitus activates *vayu*, then the *sukra* excreted due to the action of both *vayu* and *teja* reaches uterus, gets mixed with *arava*, thus formed zygote with the union of *agni* (*arava*) and *soma* (*sukra*) stays in uterus. Then the *atma* or *jiva*, known by synonyms of *ksetrajña*, *vedajña*, *sprajña*, *ghratā*, *drasjñā*, *śrota*, *rasajña*, *purusa*, *srajsjñā*, *guna*, *sāksjñā*, *dhatā* and *vaktā* etc., inspite of being *akāśa* (imperishable), *avyaya* (eternal), *actinga* (inconceivable) but due to effect of *danva* (desire), associated with *bhūta* (*prāṇamahābhūtas*), *satwa*, *raja*, *lama*, *daiva* and *asura* etc. *bhavvas* and impelled by *vāyu* reaches the uterus and stays there.

Vāgbhaṭa I corroborating the views of Caraka explains that due to effect of *rāga* (love or passion) etc. and impelled by deeds of previous life the *mana* propels *jiva* to come to the uterus.

Vāgbhaṭa II explaining this very point says further that as fire is generated from the wood by contrivance, similarly *satwa* with the association of *sukra* and *arava* forms zygote. As the rays emanating from sun or fire being emitted from quartz (*sphatikamāni*) and reaching wood are not actually seen, but are accepted because of their results i. e. heat of the sun and fire in the wood, similarly entry of *satwa* in the uterus is not seen (but is accepted due to its effect).

Kāśyapa writes that the omnipresent *jiva* having qualities of god simultaneously re-

१. ऋतौ च गर्भोऽप्यवतिष्ठते। तद्यथा-सुकृष्टक्षेत्रे बीजं प्रक्षिप्तं तत्र (यदि) ब्रीहिः ब्रीहित्वाय कस्यते, यवो यवत्वायः एकमे(भि)न्द्रियमुत्काले विपुष्टम(न)दृष्टया योने गर्भाशयमुपाच्छति। तद्यथा(५५)प(प) अकालगृहीताः प्रतीपं प्रतिवर्तन्ता। तद्वत् शुक्रशोणितं गर्भाशये अस्ति(स्थि)क(रं) क्षीरमिव। तं चा (तच्चाऽऽ)क(ज)नकमिवोदुम्बरेण (रसु)निषेकमेकत्वमपानमूर्द्धं लभते॥ (भे० सं० शां० ८२) (इस गद्य की भाषा स्पष्ट नहीं है।)

signs from former body and enters into next one, thus, it is never dissociated from *bija*, *sonita*, *vāyu* etc. *mahābhūtas*, *manu* and *budhhi*. The *jīva* due to its omnipresence does not enter randomly in either of the species, but the entry in specific species is guided by the deeds of previous life.

Bhāvanīśtra has summed up the opinions of Suśruta and Vāgbhaṭa II.

Hārta explains that from energy of *dhatu*, *satwa* is activated, from *satwa* the *rajas*; from *rajas* comes longing which results in copulation. Though in female *raja* (menstruation) is evident without efforts, however, conception can not be achieved without specific efforts. Answering the question of his pupils that why woman inspite of possessing *puspa* (flower i.e. ovum) just like trees does not conceive without copulation (while in trees fruits are formed from flowers without copulation), he says that in trees immobile *śiva* (male components) and *vyāḡra śakti* (permeated energy) or male and female both components are present, but the female possesses only *raja*, the *bija* resides in male organ, hence only after union of both conception occurs.

Bhela opines that *vāyu* carries *śukra* deposited in vagina, which with association of *ārta* makes *garbha*. Further he elaborates that as a seed of paddy or barley sown in well prepared field will nicely grow as paddy or barley, similarly healthy *śukra* deposited in healthy vagina reaches uterus by running through *ārta* of *yoni* (vagina-uterus-fallopian tubes). For some time *śukra* and *sonita* remain unstable in uterus like (liquid) milk, afterwards (both these *śukra* and *ārta*) getting mixed together give rise to all body parts just as seen in wild fig (*Ficus glomerata* in this plant flower is not explicit, but gives rise to all components of fruit).

गर्भ के मुख्य षड्घटक या षड्धातु (Six major components or sādhatu of fetus)

गर्भस्य खल्वन्तरिक्षवायुप्रितोषमिविकाराश्चेतनाधिष्ठानभूतः । एवमनया युक्त्या पञ्चमहाभूतविकासमुदा-
यात्मको गर्भश्चेतनाधिष्ठानभूतः, स ह्यस्य षष्ठो धातुरक्तः ॥ (च० सं० शा० ४/६)

महागुणमपेक्ष्य खवचनतेजो जलभूमाख्येभ्यो महाभूतेष्वश्चेतनाधिष्ठितेभ्योऽभिनिर्वृतिः ॥ (अ० सं० शा० ५/४)

गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी का विकार तथा चेतना का आश्रय स्थान है अर्थात् इस युक्ति से पञ्चमहाभूतों के विकारों का समुदायात्मक यह गर्भ चेतना का अधिष्ठानभूत होता है। यह चेतना गर्भ की छठी धातु (पाँच धातुयें = पञ्चमहाभूत एवं छठी धातु आत्मा) है। अन्यत्र भी महर्षि चरक ने गर्भ को षड्धातुत्मक वर्णित किया है।^१

अष्टांगसंग्रहकार के मतानुसार चेतना (आत्मा) के अधिष्ठान (आश्रय) में महागुणों (सत्त्व, रज, तम) से युक्त आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी महाभूत शरीर का निर्माण करते हैं अन्यत्र ओज को गर्भ का सर्वप्रथम सार या गर्भ की प्रथम धातु का प्रसाद-भाग माना है।^२

आचार्य भाविमिश्र ने गर्भोत्पादक, रक्षक एवं वर्धक पदार्थों में उपर्युक्त षड्धातु के ही साथ रज, तम एवं पंचेन्द्रियों आदि का भी उल्लेख किया है।^३

१. षड्धातुसंगोपादार्माणो सम्भवस्तथा। (च० सं० सू० ११/२३)

२. यत्तत्सामादौ गर्भस्य यतद्वर्तमानसः॥ (अ० सं० सू० ११/३५)

३. अग्नौभौ महौ वायुनमः सत्त्वं रजस्तमः। पञ्चैन्द्रियाणि भूतानां गर्भं सञ्जीवयन्ति हि॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३२०)

The embryo is product of *ākāśa*, *vāyu*, *agni*, *jala* and *prithvi* etc. five *mahābhūtas* and seat of *cetana* (*ātma*), thus *cetana* is sixth *dhatu*. Vāgbhaṭa mentions the association of *mahābhūtas* (*satwa*, *rajas* and *tamas*) alongwith above components of embryo, at other place the *ojas* is said to be essence of *garbha* or essence part of first *dhatu* of *garbha*.

मन, आत्मा एवं पञ्चमहाभूतों का गर्भ में अवतरण क्रम (The sequence of descent of *mana*, *ātma* and *pañcamahābhūtas* in embryo)

तत्र पूर्वं चेतनाधातुः सत्त्वकारणो गुणग्रहणाय प्रवर्तते, स हि हेतुः कारणं निमित्तमक्षरं कर्तुं मन्ता वेदिता बोद्धा द्रष्टा धाता ब्रह्म विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः प्रभवोऽव्ययो नित्यो गुणी ग्रहणं प्रधानमव्यक्तं जीवो ज्ञः पुद्गलश्चेतनावान् विभुर्भूतात्मा चेन्द्रियात्मा चान्तात्मा चेतितः। स गुणोपादानकालेऽन्तरिक्षं पूर्वतममेभ्यो गुणेष्व उपादत्ते, यथा-प्रत्ययान्ये सिन्धुर्भूताव्यक्षरभूत आत्मा सत्त्वोपादानः पूर्वतमाकाशं सृजति, ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान् धातुनवाव्यक्तिकंश्चतुर्ः, तथा देहग्रहणेऽपि प्रवर्तमानः पूर्वतमाकाशमेवोपादत्ते, ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान् धातुनवाव्यक्तिकंश्चतुर्ः। सर्वमपि तु खल्वेतद्गुणोपादानमगुणं कालेन भवति ॥ (च० सं० शा० ४/८)

सर्व प्रथम सत्त्व का आधार लेकर चेतना धातु गुण ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। यह आत्मा ही हेतु, कारण, निमित्त, अक्षर, कर्ता, मन्ता, वेदिता, बोद्धा, द्रष्टा, धाता, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, विश्वरूप, पुरुष, प्रभव, अव्यय, नित्य, गुणी, ग्रहण, प्रधान, अव्यक्त, जीव, ज्ञ, पुद्गल, चेतनावान्, विभु, भूतान्ता, ईन्द्रियात्मा एवं अन्तारत्मा आदि कहा जाता है। यह आत्मा गुण ग्रहण करने के समय सर्वप्रथम आकाश का निर्माण करता है। जिस प्रकार कि प्रलय के बाद भौतिक सृष्टि की इच्छा रखने वाला ब्रह्मा सत्त्व रूपी उपादान से युक्त आकाश की ही उत्पत्ति करता है, तत्पश्चात् क्रमशः व्यक्ततर गुण वाले वायु आदि चारो महाभूतों की सृष्टि करता है, उसी प्रकार शरीर के पूर्वरूप गर्भ के स्वरूप-ग्रहण के समय भी आत्मा सर्व प्रथम आकाश ही ग्रहण करता है, तत्पश्चात् क्रम से व्यक्ततर गुण वाले वायु आदि चारो धातुओं को ग्रहण करता है। इन सभी गुणों (महाभूतों) का उपादान या ग्रहण बहुत ही अल्प काल में हो जाता है।

आत्मा के देहात्तर-गमन का वर्णन करते हुए लिखा है कि आत्मा चार (आकाश को छोड़कर) सूक्ष्म महाभूतों के साथ मन की गति से एक देह (पुत्र देह) को छोड़कर, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार नवीन देह में प्रविष्ट होता है जो दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है; यह आत्मा सर्वत्र व्यापक, सभी शरीरों को धारण करने वाला, सभी कर्म करने वाला (विश्वकर्मा), सभी आवृत्ति धारण करने वाला (विश्वरूप), चेतना धातु, अतोद्भूत, (ईन्द्रियों एवं बुद्धि आदि से) सर्वदा युक्त या बँधा हुआ तथा (गण-दोष से) घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रहता है।^१

महर्षि हारीत ने लिखा है कि इस पञ्चभूतत्मक शरीर में सर्व प्रथम शून्य या आकाश होता है, आकाश से वायु, वायु से प्राण होता है। प्राण सम्पूर्ण जीवों में होने वाला सत्त्व गुण है। आकाश से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से तेज एवं तेज से तम की उत्पत्ति होती है।^२

१. देह ग्रहणेऽपि गार्भस्वरूपग्रहणेऽपि (च० सं० शा० ४/८ को चक्र० टी०)

२. भूतैश्चतुर्भिः सहितः सुसूक्ष्मैर्मनोजवो देहमुपैति देहात् कर्मफलत्वात् नु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दर्शनमस्ति रूपम्॥

स सगर्भः सर्वतरो भूज स विश्वकर्मा स च विश्वरूपः स चेतनाधातुर्लोकोन्द्रियश्च स नित्यपुक् सानुयुयः स एवा॥

(च० सं० शा० २/३१, ३२)

३. पञ्चभूतमयं देहमाकाशं शून्यमेव च। शून्याद्वायुः समुत्पन्नो वायोः प्राणः प्रजायते॥

प्राणश्च तथा जातः सर्वसत्त्वे प्रतिष्ठितः॥ ४८॥

आकाशाच्चलमुत्पन्नं जलज्जाता वसुन्धरा तस्यास्तेजस्तथा जातं तेजसो जायते तमः॥ ४९॥

(हो० सं० षष्ठस्थान १/४८, ४९)

With the help of companionship of *mana*, the *celanā dhānu* proceeds for taking hold of *guṇa* (*śarwa*, *raja* and *tama*). This very *celanā* is called as *hetu*, *kāraṇa*, *nimāṇa*, *ākṣara*, *karāṇa*, *menāṇa*, *vedāṇa*, *boddhā*, *drasṭā*, *dhātā*, *brahmā*, *viśwakarmā*, *viśvavāṇa*, *pūrasa*, *prabhava*, *avyaya*, *nitya*, *guṇā*, *grahana*, *pradhāna*, *avyakta*, *jīva*, *jīva*, *pulgaḥ*, *celanāṇā*, *vibhu*, *bhūānā*, *indriyānā* and *antarānā*. This *ātmā* at the time of beholding of *guṇas* first of all creates *ākāśa*, in the same way as after complete annihilation of entire universe, the god of creation *brahmā* first of all created *ākāśa* with the assistance of *śarwa*, followed by gradual creation of more perceptible *bhūtas* as *vāyu* etc. Similarly in the formation of embryo also first acquisition of *ākāśa* followed by more perceptible other four *bhūtas* as *vāyu* etc. occurs. In acquiring all the *mahābhūtas* time taken is very negligible.

Describing transmigration of self, Caraka writes that the self alongwith four subtle *bhūtas* and with the speed of mind transmigrates from one body to the other on the basis of past deeds, it can not be seen without divine visual sense. The self is all pervasive, sustains all bodies, performs all actions, takes all forms, is the source of consciousness, transcends all senses, is ever united and closely attached.

Hārta opines that from *ākāśa* comes *vāyu*, from *vāyu* is *prāṇa* which is *śarvaguṇa* of all the living beings. From *ākāśa* comes *jala*, from *jala* the *prithvī*, from *prithvī* is *teja* and from *teja* is *tama*.

गर्भ में पञ्चमहाभूतों के विभिन्न स्रोत (Sources of pañcamahābhūtas in fetus)

गर्भस्थ चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि मातापितृसंभवानि । आहारजान्यात्मकानि चैव सर्वस्य सर्वाणि भवन्ति देहे ॥ २६ ॥
तेषां विशेषद्वलवन्ति यानि भवन्ति मातापितृकर्मजानि । तानि व्यवस्थेत् सदृशत्वेतत् सत्त्वं यथाकामपि व्यवस्थेत् ॥ २७ ॥
रसात्ममातापितृसंभवानि भूतानि विद्याद्वयधत् च देहे । यत्नारि तत्रात्मनि संश्रानि स्थितस्तथाऽऽत्मा च चतुर्षु तेषु ॥ ३३ ॥
भूतानि मातापितृसंभवानि रजश्च शुक्रं च वदन्ति गर्भे । आप्याय्यते शुक्रमसृक् च भूतैस्तानि भूतानि रसोद्भवानि ॥ ३४ ॥
भूतानि चत्वारि तु कर्मजानि यान्यात्मलीनानि विशन्ति गर्भम् । स बीजधर्मा ह्यपरापराणि देहात्ताप्यायन्ति यानि यानि ॥ ३५ ॥
रूपाद्वि रूपप्रभवः प्रसिद्धः कर्मात्मकानां मनसो मनसः । भवन्ति ये तत्कृतिबुद्धिभेदा रजस्तमस्तत्र च कर्म हेतुः ॥ ३६ ॥

(च० सं० शा० २)

बीजान्तकैर्महाभूतैः सूक्ष्मैः सत्त्वानुपैश्व सः । मातृशुहारसजैः क्रमात्कुक्षौ विवर्धते ॥ (अ० ह० शा० १/२)

गर्भ के शरीर की उत्पत्ति में चार स्रोतों अर्थात् माता (रक्तान्त), पिता (शुक्रान्त), आहाररस (शुक्रशीणित संयोग के पश्चात् माता के आहार रस से गए हुए), एवं आत्मा (पूर्वजन्म के कर्म के वशीभूत हो आत्मा से प्रतिबद्ध) के द्वारा चार चार (वायु, तेज, जल, पृथ्वी) महाभूत आकर सभी के सभी भाग लेते हैं। इनमें से माता, पिता एवं कर्मज कारणों में से जिस कारण की विशेषरूप से प्रधानता होती है, उस प्रधान रूप के महाभूतों के सदृश एवं मन में संचादि (सत्व, रज, तम) जिस गुण की प्रधानता होती है, एवं वह मन पूर्वजन्म की जिस देह की छोड़कर आया होता है, उसके सदृश संतान की उत्पत्ति होती है; अर्थात् यदि वह देव शरीर को त्याग कर आया होता है तो देव सत्त्व, यदि पशु शरीर को

१. चत्वारितीति निविशेषमाकाशं वर्जयित्वा.....मातृसम्भवानि रक्तानि, पितृसम्भवानि शुक्रानि, आहारजानि तु शुक्रशीणितसंयोगतःकारणं मातृशुहारसंभूतसंजानि, आत्मजानि तु आत्मप्रतिबद्धकर्मवशात्प्राप्तानि ज्ञेयानि।

(च० सं० शा० २/२६ की चक्र० टी०)

त्याग कर आया होता है तो पशु सत्त्व आदि होता है। साथ ही कर्म एवं जाति का भी सम्बन्ध रहता है, अर्थात् कर्म के कारण भी मन राजस्व, तामस या सात्विक आदि होता है तथा कर्म के वशीभूत होकर ही शरीर मनुष्यादि जाति के अनुरूप होता है।^१

शरीर में रसज, आत्मज, मातृज, एवं पितृज भेद से १६ महाभूत विद्यमान रहते हैं (चा-चार महाभूतों के चार स्रोत)। आत्मज चारो महाभूत आत्मा में आश्रित रहते हैं एवं आत्मा उनमें आश्रित रहती है। गर्भ में मातृज एवं पितृज महाभूत रज और शुक्र कहे जाते हैं। रज और शुक्र की पञ्चमहाभूतों से वृद्धि होती है एवं इन पञ्चमहाभूतों की रस से पुष्टि होती है।

जो आत्मा में लीन (आश्रित) होकर चार महाभूत गर्भ में प्रवेश करते हैं वे कर्मज होते हैं। वह बीजधर्मा (गर्भोत्पत्ति के लिए या अंकुर के लिए बीज स्वरूप) आत्मा मन के साथ (कर्म के अनुसार) शुभ (देवादि) एवं अशुभ (कृमि आदि) देहांतर में गमन करती है।

आत्मा के साथ आने वाले महाभूतों का कर्म के कारण जो स्वरूप होता है, उसी प्रकार के भौतिक शरीर के रूप की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार पूर्व जन्म में जिस प्रकार का मन रहा है, कर्म से प्रभावित हो इस जन्म में उसी प्रकार के मन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो अकृति एवं बुद्धि में अन्तर होता है उसके कारण रज, तम एवं कर्म हैं।

अष्टाह्वयकार के मत से बीज (शुक्र, रज) के आधारित महाभूत, सत्त्वानुगत (आत्माश्रित) सूक्ष्म महाभूत एवं माता के आहार-रसज महाभूत सभी मिलकर क्रम से कुक्षि में गर्भ की वृद्धि करते हैं।

Four *mahābhūtas* (*vāyu*, *teja*, *jala* and *prithvī*) coming from four sources i. e. mother (through *śonita* or ovum), father (through *śūkra* or sperms), *dāṭra-rasa* (through the *rasa* derived from maternal diet for supplying nourishment to the embryo) and *ātmā* (encircling *ātmā* due to effect of the deeds of previous life) participate in the formation of embryo. The born child reflects the *bhāutika* (physical) characteristics of maternal, paternal or *ātmika* etc. factors depending upon their relative predominance; and others (psychological) depending upon the preponderance of *śarwa* etc. (*śarwa*, *raja* and *tama*) in *mana*; besides, the *mana* is also influenced by its left over previous abode, such as coming after leaving the body of *devas* or animals etc. it will have some of their characters (*daiva* or *paśu śarva* etc.). The deeds and species are also related, or in other words due to influence of deeds it will be *śāntika*, *rājās* and *tāmas* etc. and it is also due to deeds that it comes to human or other species and acquires similar characters.

विमर्श (Comments)

चरकसंहिता में सांख्य दर्शन का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। पुनर्जन्म एवं इस जन्म में होने वाले शारीरिक एवं

१. अनुक्तं प्राक्तनाद्व्यवहितं देहजातिः, तेन यथाकामिति यो देवशरीराद्व्यवधानेनगत्या भवति स देव सत्त्वो भवति, यः पशुशरीरादेति स पशुसत्त्वो भवतीत्यादि। अपिष्यद्वात् कर्मसंबन्धं जातिसंबन्धं च दर्शयति, तेन कर्मवशादापि सत्त्वं राजस्वं तामसं, सात्विकं वा भवति, तथा मानुषादिजात्यनुरूपं च भवति। (च० सं० शा० २/२७ की चक्र० टी०)

२. स बीजधर्मैत्यादि। स आत्मलीनपूतसत्त्वानो बीजधर्मा बीजस्वरूपः, बीजं हि स्वसदृशमुत्कृष्टं करोति, तेन अपमज्जान्तनीने भूतसत्त्वानः सदृशं देहरूपं भूतान्तसङ्गं कुर्वन् बीजधर्मः भवति। आत्मनीति मनोयुक्तस्मिन् पराणि श्रेष्ठानि देवादिशरीराणि, अपराणि अश्रेष्ठानि किम्यादिशरीराणीति योजनायाम्। (च० सं० शा० २/३५ की चक्र० टी०)

मानसिक वैभिन्य को, साथ ही भौतिक तन्त्र अर्थात् शुक्र एवं रज से अधिक आत्मा से सम्बन्धित मन या पूर्वजन्म-कर्म के फल का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए, हो उपर्युक्त वर्णन दिया गया है। उदाहरणार्थ यदि गर्भ में मातृज महाभूतों एवं दैव-शरीर को छोड़कर आए हुए मन में मन्त्र-गुण का प्राधान्य है तो उत्पन्न बालक मातृ-सदृश एवं दैव-सत्त्व होगा (श्रौतिक २६, २७ के अध्याय पर)। परन्तु अन्त में आचार्य ने पुनः पूर्वजन्म के कर्म की प्रधानता को दर्शाने के लिए सांख्य के मत का अनुसरण करते हुए अन्त में मिनन तथा कर्म से प्रभावित सूक्ष्म महाभूतों को ही भौतिक स्वरूप का एवं पूर्वजन्म के कर्म-फलानुसार सत्त्वादि की मन में प्रधानता के आधार पर मानसिक स्थिति का निर्माण माना है, अर्थात् यद्यपि शरीर के निर्माण में रसज, शुक्रज, रक्तज एवं कर्मज नारो ही प्रकार के महाभूत भाग लेते हैं पर आकृति एवं बुद्धि आदि के निर्माण में आत्म-कर्मज महाभूत एवं मन को ही प्रधानता रहती है।

The authors are influenced by *sāṃkhya* philosophy where in maximum emphasis is laid on the influence of the deeds of previous life through *mahabhūtas* comming along with *ātma* and *mana*. The *ākāśa* being vacuum and omnipresent does not come with any object. it is automatically incorporated in *zygote*.

गर्भ के पाञ्चभौतिक अङ्गावयव (Bhautika components of fetus)

(१) आकाशीय अङ्गावयव (Components derived from ākāśa)

आकाशात्मक शब्दः श्रोत्रं लाघवं सौक्ष्म्यं विवेकश्च। (च० सं० शा० ४/१२)

तत्राकाशजानि श्रोत्रं शब्दः स्तोतांसि विविक्तता। च। (अ० सं० शा० ५/९)

तत्र खाति देहेऽस्मिन् श्रोत्रं शब्दो विविक्तता। (अ० ह० शा० ३/३)

शब्दश्च श्रोत्रं च लाघवं च सौक्ष्म्यं च विवेकश्च मुखं च काण्डश्च कोष्ठं चाकाशात्मकानि भवन्ति॥

(का० सं० शा० ३/४)

महर्षि चरक के मत से आकाशात्मक भाव शब्द, श्रोत्रोद्भूत, लाघव, सौक्ष्म्य एवं विवेक (विवेचेद) ^१ हैं। अन्यत्र आकाशीय भावों में महान तथा अणु स्त्रोतों का भी समन्वेष किया है।

अष्टांगसंग्रहकार के मत से श्रोत्रोद्भूत, शब्द, शरीर के सभी स्त्रोतस् एवं विविक्तता (अङ्गो-प्रत्यङ्गो का विभाग) आकाशज हैं।

अष्टांगसंग्रहकार ने अष्टांगसंग्रह सदृश ही वर्णन दिया है, पर स्त्रोतस् को आकाशज नहीं माना अर्थात् इनके मत से श्रोत्रोद्भूत, शब्द एवं विविक्तता ही आकाशज हैं; परन्तु टीकाकार अरुणदत्त ने आकाश को सत्त्व-गुण-प्रधान मानकर सभी शारीरिक छिद्रों की उत्पत्ति में पंचमहाभूतों के साथ आकाश का ही प्राधान्य माना है, एवं उदाहरण-स्वरूप घट का निर्माण प्रस्तुत किया है, जिसमें मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सलिल, सूत्र आदि सभी कारणभूत होते हुये भी मृत्तिका का ही प्राधान्य रहता है उसी प्रकार छिद्रों के निर्माण में आकाश का प्राधान्य है। 'विविक्तता' का स्पष्टीकरण भी रिकता शब्द से दिया है ^३

१. विवेको विवेचेदः। (च० सं० शा० ४/१२ की चक्र० टी०)

२. यद्विवेकं यदुच्यते महानि चाणूति स्तोतांसि तदास्त्रीशः शब्दः श्रोत्रं च॥ (च० सं० शा० ७/१६)

३. खात् आकाशात् सत्त्व बहुलात्, खाति-छिद्राणि, 'भवन्ति' इति शेषः विविक्तता-शून्यता रिकता, खादेव छिद्रविशेषः।

यद्यपि छिद्रादिषु सर्वभूतानामेव व्यापारः, तथाऽप्याकाशस्यैवान् विशिष्ट कारणत्वं। यथा-घटसदृश

मृदुचक्रसलिलसूत्रादिकाणामुदाहरणवन्त्येऽपि मृद एव विशिष्टकारणत्वम्॥ (अ० ह० शा० ३/३ की अरुण० टी०)

महर्षि काश्यप ने कतिपय शारीरिक अंगों का भी परिगणन किया है, इनके मतानुसार शब्द, श्रोत्रोद्भूत, लाघव, सौक्ष्म्य, विवेक, मुख, कण्ठ एवं कोष्ठ आकाशात्मक हैं।

महर्षि हारीत ने मन, बुद्धि, निद्रा, आलस्य तथा मद को आकाश से उत्पत्ति वर्णित की है।

The opinion of authors differs slightly regarding the different components of the body derived from *ākāśa*. All these are given in tabular form.

Components	CS	AS	AH	KS
1. Śabda (sound)	+	+	+	+
2. Śrotendriya (auditory system)	+	+	+	+
3. Lāghava (lightness)	+	—	—	+
4. Saukṣmya (minuteness)	+	—	—	+
5. Viveka (division)	+	+	+	+
6. Srotasas (channels)	+	+	—	—
7. Chidras (orifices)	(big and minute) —	—	+	—
			(Arjunadatta)	

Besides above mentioned body parts Kāśyapa has included *mukha* (oral cavity), *kanthā* (throat) and *koṣṭha* (abdominal cavity) and Hārīta has enumerated *mana* (psyche), *buddhi* (intelligence), *nidrā* (sleep), *ālasya* (lethargy) and *mada* (pride).

(२) वायवीय अङ्गावयव (Components derived from vāyu)

वाय्वात्मकं स्पर्शः स्पर्शनं सौक्ष्म्यं प्रेरणं धातुव्यूहनं चेष्टाश्च शारीर्यः। (च० सं० शा० ४/१२)

वायवीयानि स्पर्शनं स्पर्शः, प्रक्षसोच्छ्वासदिपरिस्पन्दनानि लाघवं च। (अ० सं० शा० ५/१०)

वातात्स्पर्शान्मुच्छ्वासा। (अ० ह० शा० ३/३)

स्पर्शश्च स्पर्शनं च सौक्ष्म्यं प्रेरणं च धातुव्यूहनं च प्राणश्वापानश्च शरीरचेष्टा च वाय्वात्मकानि भवन्ति॥

(का० सं० शा० ३/४)

स्पर्श, स्पर्शनिर्द्भूत, रुक्षता, प्रेरण, धातुव्यूहन ^१ (धातु-रचना या धातु-वहन) एवं शरीर की सभी चेष्टायें वायवीय हैं। अन्यत्र उच्छ्वास, निश्वास, उन्मेष, निमेष, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन एवं धारण आदि क्रियाओं का भी समन्वेष है।

अष्टांगसंग्रहकार के मत से स्पर्शनिर्द्भूत, स्पर्श, प्रक्षस, उच्छ्वास, परिस्पन्दन (शरीर की चेष्टाएँ) एवं लाघव वायवीय हैं।

१. मनोबुद्धिस्तथा निद्रा आलस्यं मद एव चा शून्यात्सञ्च प्रजायन्ते देहे देहे व्यवस्थिताः॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १/४४, ४५)

२. धातुव्यूहनं धातुरचना धातुवहनं च। (च० सं० शा० ४/१२ की चक्र० टी०)

३. यदुच्छ्वास प्रक्षसोन्मेषनिमेषकुञ्चनप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तद्वायवीयं स्पर्शः स्पर्शनं च॥ (च० सं० शा० ७/१६)

अष्टाङ्गहृदय रचयिता ने केवल स्पर्श एवं उष्णत्व को वातज तथा वायु को रजो-बहुल माना है। महर्षि कारश्य ने चरक वर्णित सभी अवयवों को गणना के लिये साध प्राण एवं अपान को भी वायवीय भावों के अन्तर्गत गणना की है।

महर्षि हरीत ने कर्ण, स्पर्श, उष्णत्व, स्वेद, चक्रमण तथा वात के लक्षणों को वायु से उत्पत्ति मानी है।

The components derived from *vāyu* are given here under :—

Components	CS	AS	AH	KS	Hā.S
<i>Sparsā</i> (sense of touch)	+	+	+	+	+
<i>Sparsānendriya</i> (organs of sense of touch)	+	+	—	+	—
<i>Rauksya</i> (roughness)	+	—	—	+	—
<i>Prerana</i> (impulsion)	+	—	—	+	—
<i>Cesā</i> or, <i>parispandana</i> (activity of body)	+	+	—	+	—
<i>Dhātū-vyūhana</i> (formation or transportation of <i>dhātus</i>)	+	—	—	+	—
<i>Ucchvāsa</i> (expiration)	+	+	+	—	+

Beside these inspiration, opening and closure of eye-lids, contraction and relaxation, movement, propulsion and retention by Caraka, *laghava* (lightness) and *prāśvāsa* (inspiration) by Vāgbhata I; *prāṇa* and *apāna* by Kāśyapa and *karṇa* (ear), *sweda* (sweat or perspiration), *cankramana* (walking) and other characteristics of *vāta* by Hārīta have also been enumerated.

(३) आग्नेय अङ्गावयव (Components derived from *agni*)

अग्न्यात्मकं रूपं दर्शनं प्रकाशः पक्तौषयं च । (च० सं० शा० ४/१२)

आग्नेयानि दर्शनं रूपं पित्तमूष्मा पक्तिः सत्तापो मेधा वर्णो भास्त्रेचः शौर्यं च ॥

(अ० सं० शा० ५/११)

वह्नेरुत्पत्तयः । (अ० ह० शा० ३/३)

रूपं च चक्षुष्य प्रकाशश्च पित्तं च पक्तिश्चोष्मा च शरीरवृद्धिश्च तैजसनि भवन्ति ॥

(का० सं० शा० ३/४)

महर्षि चरक ने रूप, इन्द्रिय, प्रकाश, पक्ति (पाचन-क्रिया) एवं शरीर की उज्जता को आग्नेय वर्णित किया है। अन्यत्र आग्नेय भावों से प्रकाश का भी समावेश है।

१. ज्ञातात् -अनितान्बोबुलात् । (अ० ह० शा० ३/३ को अरण्य० टी०)
२. श्रुतिः स्मरितयोश्चवासः स्वेदं चक्रमणदि च वाता ह्येते पक्षिण्या अग्न्या प्रकृतिरेव च । (ह० सं० षष्ठ्यान् १/४३, ४४)
३. यत् पित्तमूष्मा च यो या च पाः शरीरे तत् सर्वमानेयं रूपं दर्शनं च ॥ (च० सं० शा० ७/१६)

अष्टाङ्गसंग्रहकार के मत से दर्शनीन्द्रिय, रूप, पित्त, शरीर की ऊष्मा, पक्ति, सत्ताप, मेधा, वर्ण, कौटि, तेज एवं शौर्य आदि आग्नेय भाव हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने दृशीन्द्रिय, रूप एवं पक्ति (पाक) आग्नेय भाव माने हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने अग्नि को सत्त्व-रजो-बहुल तथा पित्त, ऊष्मा मेधा, वर्ण, शौर्य आदि को भी आग्नेय माना है।

महर्षि कारश्य ने रूप, चक्षु, प्रकाश, पित्त, पक्ति, ऊष्मा, शरीर की वृद्धि एवं तेज को आग्नेय माना है।

महर्षि हरीत ने अग्नि के द्वारा पित्त, नेत्र (दो), तम तथा क्रोधादि पाँच को उत्पत्ति मानी है।

The opinion of authors about body components derived from *agni* is given here under :

Components	C	AS	AH	KS	Hā.S
<i>Rūpa</i> (form)	+	+	+	+	—
<i>Cakṣu indriya</i> (ophthalmic apparatus)	+	+	+	+	+
<i>Pakti</i> (metabolism)	+	+	+	+	—
<i>Īśma</i> (body heat)	+	+	+	+	—
<i>Prakāśa</i> (light)	+	—	—	+	—
<i>Pitta</i> (metabolic enzymes)	+	+	+	+	+
<i>Teja</i> (sharpness or brightness)	—	+	—	+	—
<i>Bhā</i> (lustre)	+	—	—	—	—
<i>Darśana</i> (visual sense)	+	—	—	—	—

* given by Arunadatta.

Besides these *medhā* (brain), *varṇa* (complexion), *śāmya* (valour or prowess) by Vāgbhata I and Arunadatta, *sanjāya* (temperature) and *kānti* (splendour) by Vāgbhata I; *śānta-vyadhi* (growth of body) by Kāśyapa, *tama* (darkness) and *krodha* (anger) by Hārīta have been included.

(४) जलीय अङ्गावयव (Components derived from *jala*)

अवात्मकं रसो रसनं शैत्यं मार्दवं स्नेहः क्लेदश्च । (च० सं० शा० ४/१२)

आम्भसानि रसनं रसः स्वेदक्लेदवसासुक्शुक्रमूत्रादिवसमूहाः शैथिल्यं स्नेहश्च ।

(अ० सं० शा० ५/१२)

आप्या जिह्वारसक्तेदा । (अ० ह० शा० ३/४)

रसश्च रसनं च शैत्यं च मार्दवं च द्रवश्च स्नेहश्च क्लेदश्च रलेष्वा च भेदश्च रक्तं च मांसं च शुक्रं चाप्यानि भवन्ति ॥

(का० सं० शा० ३/४)

रस, रसोन्मिन्द्रिय, शीतलता, मृदुता, स्नेह एवं क्लेद का जलीय भावों के अन्तर्गत महर्षि चरक ने उल्लेख किया है। पुनः श्रुति लिखा है कि जो भी द्रव, सर, मन्द, स्निग्ध, मृदु, पिच्छल, रस, शीघ्र, वसा, कफ, पित्त, मूत्र स्वेदादि है वे आप्य

१. वन्देः सत्त्वजोबुलात् । (अ० ह० शा० ३/३ को अरण्य० टीका)
२. अग्निं पित्तञ्च नेत्रञ्च तमः क्रोधादिष्वङ्कम । (ह० सं० षष्ठ्यान् १/४३)

भाव है।^१

अष्टांगसंग्रहकार ने चरकोक्त भावों के साथ कुछ अन्य विशिष्ट अवयवों का समावेश करते हुए लिखा है कि रसनोद्विग्न, रस, स्नेह, क्लेद, तन्म, अमृक, शुक्र, मूत्रादि द्रव समूह, शैथिल्य एवं स्नेह आदि जलीय भाव हैं।

अष्टांगहृदयकार ने केवल जिह्वा (रसनोद्विग्न), रस एवं क्लेद का वर्णन दिया है। टीकाकार अरुणदत्त ने जल को सत्व-तमो-वह्नुल माना है।^२

महर्षि काश्यप के मत से रस, रसनोद्विग्न, शैथ, मार्दव, द्रव, स्नेह, क्लेद, श्लेष्मा, मेद, रक्त, मांस तथा शुक्र जलीय भाव हैं।

महर्षि हरीत ने रस, रक्त, लाला, मूत्र तथा शुक्र जो जलीय माना है।^३

Different body parts developing from *jala* are being given here under:

Components	CS	AS	AH	KS	Hā.S
<i>Rasa</i> (taste)	+	+	+	+	+
<i>Rasaneन्द्रिया</i> (gustatory system)	+	+	+	+	—
<i>Sāilya</i> (coldness)	+	—	—	+	—
<i>Mārdava</i> (softness)	+	—	—	+	—
<i>Sneha</i> (unctuousness)	+	+	—	+	—
<i>Kleda</i> (moisture)	+	+	+	+	—
<i>Asrk</i> (blood)	+	+	—	+	+
<i>Śukra</i> (sperm)	—	+	—	+	+
Urine etc. watery substances	+	+	—	+	+
<i>Vasā</i> or <i>Meda</i> (fat)	+	+	—	+	—

Alongwith above components others like all liquids, mobile, dull, soft, slimy, *rasa*, *kapha*, *piita* and sweat by Caraka; *sweda* (sweat or perspiration) and *śāithilya* (laxity) by Vāgbhata I, *māmsa* (muscles) by Kāśyapa and *izā* (saliva) by Hārta have been described.

(५) पार्थिव अद्भावयव (Components derived from Prithvi)

पृथिव्यात्मकं गन्धो घ्राणं गौरवं स्पर्शं मूर्तिश्चेति। (च० सं० शा० ४/१२)

पार्थिवानि घ्राणं गन्धः केशनखास्थ्यादिमूर्तिसमूहो धैर्यं गौरवं च। (अ० सं० शा० ५/१३)

घ्राणगन्धास्थिपार्थिवम्। (अ० ह० शा० ३/४)

गन्धश्च घ्राणं च गौरवं च स्पर्शं च मूर्तिश्च पार्थिवानि भवन्ति॥ (का० सं० शा० ३/४)

महर्षि चक्र ने गन्ध, घ्राणोद्विग्न, गौरव, स्थिरता एवं शारीरिक मूर्ति (काठिन्य)^४ को पार्थिव माना है पुनश्च विस्तृत

१. यद्रूपसामान्यपदुपिच्छलं रसलभिवसाकफपित्तभूतस्नेहादि तत्प्राप्य रसो रसनं च॥ (च० सं० शा० ७/१६)
२. अल्पः सत्त्वतो बहुलाप्यो जाता। (अ० ह० शा० ३/३ की अरण्य टीका)
३. रसं रक्तञ्च लालाञ्च मूत्रं शुक्रं जलानि च॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १/४२)
४. मूर्ति काठिन्यम्। (च० सं० शा० ४/१२ की चक्रप्राणि टीका)

वर्णन करते हुए स्थूल, गुरु, खर एवं कठिन अङ्ग, नख, अस्थि, दन्त, मांस, चर्म, वर्च, केश, श्मश्रु, लेप एवं कण्डरा आदि का भी समावेश किया है।^१

अष्टांगसंग्रहकार के मत से घ्राणोद्विग्न, गन्ध, केश, नख, अस्थि आदि मूर्तिसमूह, धैर्य एवं गौरव पार्थिव भाव हैं।

अष्टांगहृदयकार ने घ्राणोद्विग्न, गन्ध एवं अस्थि का उल्लेख किया है। पृथ्वी को तमो-बहुल टीकाकार अरुणदत्त ने माना है।^२

महर्षि काश्यप ने वर्णन में चरक का अक्षरशः पालन करते हुए गन्ध, घ्राणोद्विग्न, गौरव, एवं मूर्तिव पार्थिव भाव माने हैं।

महर्षि हरीत ने त्वक्, मांस, केश, रोम एवं अस्थि को पृथ्वी से उत्पन्न माना है।^३

The body component developing from *prithvi* are given here under:

Components	CS	AS	AH	KS	Hā.S
<i>Gandha</i> (smell)	+	+	+	+	—
<i>Ghṛāṇendriya</i> (olfactory organs)	+	+	+	+	—
<i>Gaurava</i> (heaviness)	+	+	—	+	—
<i>Sthairya</i> (stability)	+	—	—	+	—
<i>Mūrti</i> (stiffness or structure of body)	+	—	—	+	—
<i>Keśa</i> (hair)	+	+	—	—	+
<i>Ashti</i> (bones)	+	+	+	—	+

Other components described are particularly thick, heavy, coarse, and hard body-parts, nails, bones, teeth, flesh, skin, feces, hair, moustaches, body-hair and tendons etc by Caraka; *nakhā* (nail) and *dhairya* (patience) by Vāgbhata I and *twaka* (skin), *māmsa* (muscle) and *roma* (body hair) by Hārta.

गर्भ की वृद्धि में पञ्चमहाभूतों का कार्य (Specific function of pañcamahabhūtas in fetal development)

तं चेतनावस्थितं वायुर्बभजति, तेज एनं पचति, अपः क्लेदयन्ति, पृथिवी संहन्ति, आकाशं विवर्धयति।

(सु० सं० शा० ५/३)

इस चेतनावस्थित गर्भ में वायु विभाजन, तेज पाचन, जल क्लेदना, पृथ्वी संहनन एवं आकाश विवर्धन करता है।

टीकाकार डल्हण ने उभयैक गद्य का स्पष्टीकरण करते हुये लिखा है कि चेतना के ही कारण गर्भ प्रसव-काल तक स्थिर रहता है, चेतना-विहीन होने पर कुशित या विशीर्ण हो जाता है। वायु उसमें (गर्भापिंड में) दोष, धातु, मल, अंग एवं प्रत्यंग आदि का विभाजन करती है। तेज पाचन करके रूप से रूपान्तर की अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात् गर्भ

१. तत्र यद्विशेषः स्मृतं स्थिरं मूर्तिमदगुल्लकाठिनमङ्गं नखस्थिततंसंस्पर्शवर्चः केशमश्रुलोमकण्डरादि तत् पार्थिवं गन्धं घ्राणं च॥ (च० सं० शा० ७/१६)
२. पृथिव्याख्यातमोबहुलाप्य। (अ० ह० शा० ३/३ की अरण्य टी०)
३. त्वङ्मांसकेशरोमास्थिभूषणं जनयेत्तथा॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १/४२)

को मनुष्य आदि का रूप प्रदान करता है तथा उस मनुष्य को अपना रूप एवं वर्ण आदि देता है। जल इस गर्भ में क्लेदरन करता है अर्थात् वायु के विभाग आदि के कारण तथा अग्नि से उत्पन्न शोषण या शुष्कता की आर्द्रता करता है। पृथ्वी संहरन करती है अर्थात् जल से क्लिप्त उस गर्भ को काठिन्य देकर मूर्तिमान करती है। आकाश विवर्धन करता है अर्थात् वायु एवं अग्नि के द्वारा विद्वलित तथा ऊर्ध्व, अधो एवं तिर्यक् या सभी ओर को बढ़ते हुये सोतसों में आम्नापन द्वारा अवकाश प्रदान कर विवर्धन करता है।^१

आचार्य भावमिश्र ने अग्नि (तेज) को पाचक, अलोचक, रंजक, भाजक तथा साधक पित के रूप में तथा पाञ्चभौतिक एवं सप्तधात्विक के रूप में शरीर में स्थित बताया है तथा इसे वर्णों का आधिदेव भी कहा है। इसका कार्य शरीर में पाचन आदि कर्म के द्वारा गर्भ को जीवित रखना है। जल का वर्णन इस प्रकार किया है कि सोम (जल) पाँचों प्रकार के जनेष्वा, रस, शुक्रादि जलात्मक भावों के रूप में तथा रसोन्मिय की शक्ति के रूप में अवस्थित मन का आधिदेव है। यही सोम ओज-प्रभृति सौम्य धातु का पोषण करने से तथा वायु एवं अग्नि से शुष्क हुए भाग को आर्द्र करने से गर्भ को जीवित रखता है। पृथ्वी, वायु एवं आकाश का वर्णन टीकाकार डल्हण सदृश ही किया है।^१

In *cetana* (alive) *garbha* (embryo) *vibhāṅga* (division), *pācana* (metabolism), *kledana* (moistening), *samhānana* (solidification) and *vivardhana* (increase in size) are done by *vāyu*, *teja*, *jala*, *prthivī* and *ākāśa* respectively. Dalhana clarifying the above verse says that only because of *cetana* the *garbha* remains alive upto the time of delivery, in absence of this it gets putrified or degenerated. The division of *doṣa*, *dhatu*, *mala* (excretas), *aṅga* and *pratyāṅga* (major and minor body parts) is done by *vāyu*. The *teja* by its function of metabolism changes the shape, provides general appearance like human structure etc. along with specific features and complexion. Moistening is done by *jala* or in other words the dryness or absorption caused by division and metabolism being done by *vāyu* and *teja* respectively is normalized by moistening action of *jala*. The *prthivī* solidifies or gives shape to the embryo already moistened by *jala*. The increase in size is done by *ākāśa* by providing vacuum with *ālmāpāna* (inflating or blowing upon) to the *śrotras* (channels) running all-around the body i.e. in up, down and oblique directions, which are created by *vidāraṇa* (splitting or division) done by *vāyu* and *agni*.

Bhāvamiśra corroborating the earlier views regarding *prthivī*, *vāyu* and *ākāśa* explains that *agni* or *teja* stays in the body in the form of *pācaka*, *ālocaka*, *rañjaka*, *bhāvaka* and *sādhaka pita* alongwith specific *agnis* of *pāñcamahābhūtas* and seven *dhatūs*. It is

१. चेतना हेतुभूता यावद् गर्भप्रसवकालमवस्थितं चेतनावस्थितं, अन्यथा कुशितविशेषो^१ स्यात्। तं वायुर्भ्रमन्ति दोषधातुमलाश्चर्यद्विविभागेन। तेज एतं पचति रूपादृपात्तोष्णत्वस्थानं प्रापयति। आग्नः क्लेदयन्ति विभागगीष्माण-काण्योर्निलानलयोः शोषणेऽप्यर्द्रतां जनयन्ति, पृथिवी संहरति अद्रिः क्लिप्तमपि कठिनं मूर्तिमन् करोति। आकाशं विवर्दयन्ति अनिलानलविदारितोत्तमाध्माध्मनेन्दुर्ध्वमथिस्तिर्यग्बिम्बवर्धितमकाशधनेन विवर्धयन्ति।

(सु० सं० शा० ५/३ की डल्हण० टी०)

२. अग्निप्र-पाचकालोचकभाजकसाधकनामः तथा पाञ्चभौतिकानां तथा सप्तधातुगणनामग्र्यां शक्तिरूपतयाऽवस्थितो वाचोऽधिदेवत्वं प्राप्नो बोद्धव्यः, स च पाचकारिकर्मणो जीवयति। सोमश्च-पञ्चातकरोत्तमस्शुक्रादीनां तोयान्मकानां भवानां रसोऽन्मियस्य च शक्तिरूपतयाऽवस्थितो मनश्चाधिदेवत्वं प्राप्नो बोद्धव्यः, स च सौम्यालोतेजः प्रभृतेः पोषणेन पवनपाचकसंशुष्कभगस्यर्द्रताविधानेन जीवतीति शेषः। मही च-जलेन क्लिप्तमस्यापि कठिनीविधानेन। वायुर्दोषधातुमलाश्चोपमृद्नीनां सञ्चारणेनोच्छ्वासनिःश्वासाप्याह। नभो-(उन्मिलनलविदारितोत्तमाध्माध्मनिस्तिर्यग्बिम्बवर्धितमकाश-धनेन)। (पा० प्र० पूर्व० ३/३२०)

ādhideva (god or commander) of *vāyu* (speech). By performing metabolic functions it maintains the life of fetus. *Jala* stays in the body in the form of all the five types of *śleṣmā*, *rasa* and *śukra* etc. liquid substances and power of taste organ. It is god of *mana*. This very *jala* or *soma* by nourishing *oja* etc. *dhatūs* and moistening the dryness created by *vāyu* and *agni* maintains the life of fetus.

विमर्श (Comments)

सामान्य सृष्टि से शरीर को तुलना करते हुये सभी पाञ्चभौतिक तत्वों का वर्णन सभी संहिताओं में मिलता है। महर्षि चरक ने स्पष्ट लिखा है कि लोक एवं पुरुष में सभी भाव समान रूप से स्थित होते हैं।^१ वर्णन में विभिन्न आचार्यों के मत में कुछ वैभिन्न्य है, जैसे लाषव को महर्षि चरक ने आकाशीय परन्तु महर्षि वाग्भट ने वायवीय माना है। विवेक, विविकता या विच्छेद कार्य महर्षि चरक एवं वाग्भट के मत से आकाश का है परन्तु महर्षि सुश्रुत ने विभाजन कार्य वायु का बताया है। महर्षि सुश्रुत ने विवर्धन या शारीरिक वृद्धि को आकाशीय भाव माना है जब कि महर्षि काश्यप ने आग्नेय।

यद्यपि अग्रे महर्षियों ने गर्भ के मातृज, पितृज आदि अङ्गों का भी वर्णन दिया है परन्तु महर्षि चरक ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मातृज आदि भाव भी पाञ्चभौतिक ही होते हैं।^२ अर्थात् शरीर के सभी घटक पाञ्चभौतिक ही होते हैं, विभिन्न भूतों की स्थिति में तर, तम का ही भेद होता है।

In preceding pages specific organs are mentioned to have been derived from specific *bhūtas*. Similarly in subsequent pages certain body parts derived from maternal *biṅa* (ovum) etc. would be described. Each and every body part is *pāñcabhauṭika*, the mention of specific *bhūtas* shows its relative predominance over the other.

गर्भ की वृद्धि में वायु की प्रधानता (The importance of *vāyu* in fetal development)

गर्भस्य खलु रसनिपिता भारताध्मानिपिता च परीवृद्धिर्भवति।

तस्यान्तेषां नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं ध्रुवं स्मृतम्। तदाधमति वातस्तु देहसेनास्य वयति ॥

ऊष्मणा सहितश्चापि दारयस्तस्य मारुतः। ऊर्ध्वं तिप्रायस्ताच्च स्त्रोतस्थपि यथा तथा ॥

(सु० सं० शा० ४/५७ से ५९)

वायुर्हि कालसहितः शरीरं विषजति संदधति चेति ॥ (का० सं० शा० ३/४)

स्वभावात्ते ह्यस्य वायुप्रमाणवः संयोगविभागचोष्णिकाता आकुञ्चनप्रसारणकोष्ठाङ्गप्रत्यङ्गधातुचेतनास्त्रोतांसि विषजन्ति ॥ (का० सं० शा० ५/३)

यद्यपि गर्भाक्रान्ति आदि का वर्णन करते समय महर्षि चरक ने वायु की प्रधानता का विशिष्ट उल्लेख नहीं किया परन्तु वायु के सामान्य कार्यों का उल्लेख करते समय इसे गर्भ की आकृति का निर्माणकर्ता माना है।^३

गर्भ की वृद्धि के लिये वायु की प्रधानता का वर्णन करते हुये महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि गर्भ की वृद्धि निश्चित रूप से रस-निमित्त (माता से प्राप्त आहार-रस के कारण) तथा वायु के द्वारा आम्नापन के कारण होती है। नाभि के अन्तर में (उदरगुहा में) निश्चित ही ज्योतिःस्थान (अग्नि का स्थान) होता है। वायु उसको (उस स्थान की अग्नि को) प्रध्मापन

१. एवमयं लोकसीमातः पुरुषः। यावन्तो हि लोकं मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तो लोके इति, वृषारत्नत्वं दृष्टुमिच्छन्ति॥ (च० सं० शा० ४/१३)

२. मातृजातयोऽप्यस्य महाप्रायविकाता एव। (च० सं० शा० ४/१२)

३. वायुः..... कर्ता गर्भाकृतीनाम्.....। (च० सं० सू० १३/८)

से प्रदेत कर्तते है, जिससे शरीर परिवर्धित होता है। इसी ऊष्मा से संयुक्त हुई वायु जैसे जैसे ऊपर, नीचे तथा तिर्यक् दिशा में स्रोतों का विदारण कर्तती है (वैसे वैसे गर्भ की वृद्धि होती है)।

महर्षि काश्यप के मत से यह वायु ही काल के सहित शरीर का विभाजन एवं धारण कर्तती है।

महर्षि काश्यप इस कथन की पुष्टि करते हुये अन्यत्र लिखते हैं कि संयोग, विभाण तथा चेष्टा को करने वाले वायु के परमाणु स्वभाव से ही अकुञ्चन, प्रसारण, अङ्ग, प्रत्यङ्ग, धातु, चेतना एवं स्रोतों का विभाजन करते हैं।

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत-वर्णित ५८ एवं ५९ श्लोक को ही उद्धृत कर दिया है केवल प्रथम एवं अंतिम पंक्ति में एक एक अक्षर का अन्तर है।^१

महर्षि हारीत ने वायु के साथ अग्नि की भी प्रधानता बताई है, परन्तु इन्होंने भी वायु का ही अधिकतम योगदान बताया है कि पंचभूतों की अग्नि बीज (एवं आर्तव) को लेकर परिपक्व करके कलल का रूप देती है, वह अंतःस्थित कलल वाला वात के संयोग से बुद्बुदकार हो जाता है। पुनः वह कलल होकर पंचमहाभूतों की अग्नि से पिण्ड रूप हो जाता है। वह पिण्ड परिपाक हो घन का संघात बन जाता है तथा व्यान वायु पञ्चतत्त्व, हस्त, पाद, शिर तथा अवयवों का निर्माण कर्तती है, तथा अंतःस्थित एक ही वायु अनेकों स्थानों में समीश्रित होकर उस पिण्ड को देहाकार कर देती है। गले एवं हृदय में स्थित उदान वायु शरीर के मुखद्वार को प्रकाशित कर्तती है या निर्माण कर्तती है। अधस्थ अपान वायु अपानद्वार का विशेषण कर्तती है या निर्माण कर्तती है। इसी प्रकार अन्तःस्थित सभी वायु पृथक् पृथक् मार्गों से छिद्र करके निकलती है जिससे वात के प्रभाव से मुख, घ्राण (दो), कर्ण (दो), नेत्र (दो) अपानपथ तथा मेहन या मूत्रद्वार आदि नवद्वार बनते हैं। वहाँ पर (गर्भपिण्ड में) अन्तःस्थित वायु विस्तृत होकर हाथ, पैर आदि अन्य अङ्गों को उत्पन्न कर देती है।^२

महर्षि भेल ने अग्नि एवं वायु की प्रधानता का वर्णन करते हुए लिखा है, कि ये अग्नि एवं वायु ही प्रविष्ट होकर अङ्गों-प्रत्यङ्गों का निर्माण करते हैं, ये ही चेष्टा करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। जब ये ही शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर वायु एवं ऊष्मा से रहित श्रेत (मृत) हो जाता है। महर्षि भद्राज कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत शरीर भी वायु से आध्यात्मित तथा अग्नि से शोषित होता है। भगवान् आश्विन ने कहा ऐसा नहीं है अन्तःस्थित अग्नि एवं वायु जीवित अवस्था में रहते हैं उनके समाप्त हो जाने पर बाहर के अग्नि एवं वायु प्रविष्ट होते हैं तथा मृत शरीर का आध्यात्मन एवं शापण करते हैं।^३

१. गर्भस्य नाभि मध्ये तु ज्योतिःस्थानं।.....

.....। ऊर्ध्वं त्रिर्धाषस्ताब्ध स्रोतोऽसि तु यथा तथा॥

यदा दारयाति विस्तारयाति तथा देहो वर्धते इति पूर्वोक्तान्ययः। (पा० प्र० पूर्व० ३/३२३, ३२४ - शेष सु० सं० सदृश)

२. अथ बीजतलेहि (बीजवेध हि-शु० पा०) पञ्चभूताग्निना परिपक्वं कललं क्रियते। सोऽपि चान्तःस्थो वायुर्बुद्बुदकारो

ब्राह्मवातेन संभूतो भवति। स च कलले भूत्वा पञ्चभूताग्निना पिण्डं जनयति। तच्च पिण्डं परिपक्वं गतं घनसंघातश्च जातं व्यानवातेन पञ्चतत्त्वानि हस्तपादादीन्धोऽवयवान्मञ्जनयति। अन्तःस्थो वायुर्कोऽपि नानास्थानं समीश्रित्य देहाकारं करोति। उदानो गालहृदयस्थितो देहमुखद्वारं प्रकाशयति। अपानवायुराधःस्थोऽपानद्वारं विशेषयति। एते चान्तःस्थाः पृथक्पृथक् मार्गं छिद्रं कृत्वा निगच्छन्ति। तान्नेव नवद्वाराणि मुखघ्राणकर्णनेत्रागानमेहानि चैतानि द्वाराणि वातेन प्रभवन्ति। तज्जातःस्थो वायुःश्रतन्त्रेन हस्तापादानवयवान्मञ्जनयति। (हा० सं० षष्ठस्थान १/४१)

३. (अथ यदाऽग्निमालौ) विस्तारः वा(ता)वेतवङ्गप्रत्यङ्गानि विकुलतः, तौ चेष्ट(य)तः, तौ वर्धयतः तामैव यद शरीराध(र)पञ्कामतः तदा तद्वद्वति निवर्तते(ते), निरुब्ध(म्), श्रेतो मृत इति। नेत्याह भद्राजः, मुनेऽपि जन्तुर्वायुना ध्यायते अग्निना शोष्यते। नेत्याह भगवानाश्विनः, सह वा तस्या(ऽन्तर)ग्निमालौ बीजवदः; तयोपरमञ्जनतयोर्वायैव(र्वाहो)पि-मालावाविशत इति॥ (धे० सं० शा० ६/३)

The development of the fetus mainly depends upon the inflation done by *vāyu* and nourishment supplied by *rasa* is the opinion of Suśruta and Bhāvamiśra. Behind the umbilicus there is definitely the location of *jyotiśhāna* (the place of light or fire). The *vāyu* by its blowing action excites or stimulates this fire, which in turn performs development of body. The *vāyu* associated with this very fire splits the upward, downward and obliquely running channels, resulting into development of fetus. It also gives specific shape or features to the fetus is the opinion of Caraka.

Kāśyapa says that finest particles of *vāyu* responsible for union, division and activity perform flexion and extension etc. actions as well as division of major and minor body parts, *dhiātū*, *cetana* (consciousness) and channels due to their specific nature. All this splitting and *dhiāraya* (retention) is done by *vāyu* in association with *kāla* (time factor).

Hārta opines that *bīja* (sperms and ovum both together) attains the shape of *kalala* by the action of *agni* situated in all the five *bhūtas*. Further this internally situated *kalala* gets the shape of *budbuda* by the action of outside *vāyu*. This *budbuda* again becoming *kalala* gets solidified in the shape of *piṇḍa* (solid) by the action of *pañcābhūtāgni*: by further metabolism this mass becomes a heap of solid substance, then *vyāna vāyu* forms the *pañcātāmas*, arms, legs and head etc. body parts. The same internally situated one *vāyu* reaching different parts gives this solid mass a shape of body. *Udāna vāyu* situated in neck and heart forms oral cavity and its aperture. *Apāna vāyu* situated downwards clarifies the *apāna dāvāra* (anal orifice), similarly internally situated *vāyu* comes out of the body making different orifices. Thus with the influence of *vāyu*, nine external meatuses i. e. oral, both nasal, both eyes, both ears, anal and urinary are formed.

Bhela lays equal emphasis on the role of *agni* and *vāyu*, both these entering the body form different major and minor body parts, as well as initiate activity and growth. When these come out of the body, the person (fetus) becomes dead due to absence of *agni* and *vāyu*. Bhāradvāja contradicts this saying that it is not so, because dead body gets inflated and dried too. Atreya corroborates the views of Bhela explaining that internal *agni* and *vāyu* exist only during life, after death the inflation and desiccation is done by external *vāyu* and *agni* which enter the dead body.

गर्भ की मानुजादि भावों के समुदाय से उत्पत्ति (Formation of garbha with the combination of maternal etc. all the components)

आयुर्वेद-दर्शन के आधार पर मानव शरीर पाञ्चभौतिक है। पूर्वपुरुषों में उल्लिखित गर्भ में पञ्चमहाभूतों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करते समय आचार्यों ने माता, पिता, रस एवं आत्मा का उल्लेख किया है। सत्त्व आत्मा के ही साथ सम्बन्धित रहता है। माता एवं पिता का शोषित तथा शुक्र किसी सीमा तक उनके सात्व्य सेवन पर आधारित होता है, इसी विचारधारा से प्रेरित होकर गर्भ के निर्माण में षड्भावों (मातृज, पितृज, रसज, सात्व्यज, आत्मज एवं सत्त्वज) की कल्पना की गई है। महर्षि चक्र ने इस विषय पर उपस्थित सम्भाषण का उल्लेख अपनी संहिता में किया है कि न तो माता, न पिता, न आत्मा, न सात्व्य, न भक्ष्य या लेह्यादि पानाशन का उपयोग गर्भ की उत्पत्ति करता है; और न सत्त्व ही परलोक से आकर

गर्भ में प्रवेश करता है अर्थात् यत्र गर्भ माता, पिता, सत्व, आत्मा, रस या सत्व में से किसी एक से उत्पन्न नहीं होता^१ बल्कि उनके समुदायरूप में एकत्र होने पर ही उत्पन्न होता है।^१ गर्भ की समुदाय से उत्पत्ति का उदाहरण महर्षि चरक ने कूटगारा एवं रथ के निर्माण में दिया है, अर्थात् जिस प्रकार नाना द्रव्य समुदाय से कूटगारा का निर्माण होता है; रथ के विभिन्न अङ्गों के समुदाय में रथ की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार माता-पिता आदि समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है।^१ महर्षि चरक ने अपने पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए माता-पिता-रसादि में से एक एक के स्वतंत्र कारणात्त्व का खण्डन, उनका महत्व एवं उनसे उत्पन्न होने वाले अङ्गों का वर्णन किया है। महर्षि भेल ने भी चरक के सदृश समुदाय से ही गर्भ की उत्पत्ति मानी है।

Ayurvedic philosophy believes that the human body is composed of five *mudhābhūtas*, sources of these *mudhābhūtas* are said to be mother, father, *rasa* and *ātma*. *Ātma* is always associated with *satwa*. The normalcy of *sonita* (ovum) and *śukra* (sperms) of mother and father respectively greatly depend upon the use of *sāmya* (wholesome, suitable or congenial diet). Considering this fact the formation of *garbha* (embryo) is said to be from *śādhabhūtas* (six components i.e. *mātrija*, *pitija*, *rasaja*, *ātmaja*, *sarvaja* and *sāmyaja bhūtas*). Caraka has recapitulated the debate on this subject. He writes that neither mother, nor father, nor *ātma* (soul / self) nor wholesome suitable diet, nor use of eatable, lickable or drinkable dietetics are capable of forming the fetus. Neither the *sarva* coming from other world enters the fetus, or in other words none of these factors singularly are capable of forming the embryo, it is formed only with combination of all these. Caraka has simulated the formation of embryo with building of upper room (apartment at the top of the house) or a chariot. As by combining and arranging different building materials the upper room is constructed or with different parts a chariot is assembled, similarly with the combination of these six components the fetus is formed. He has further advanced logic to support his view by describing different body parts arising from these specific components and thus has contradicted the theory of formation of *garbha* by singular component. Bhela has also given almost similar description albeit in summarized form.

१. न हि माता न पिता नात्मा न सत्वम् न पानाशनभक्ष्यलैक्ष्ययोगो गर्भं जनयति, न च फलोकोदित्य गर्भं सत्वमवक्रामति ॥ ३ (१२) ॥ अमरुजज्ञाश्चार्थोऽपितृजज्ञानात्सत्वश्चासत्त्वश्चासजश्च, न चास्ति सत्वमौपपादुकमिति ॥ ४ ॥ (च० सं० शा० ३/३ (१), ४)
२. (अ) च० सं० शा० ३/३ (पृष्ठ १०६)
- (आ) सर्वेभ्य एष्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भोऽभिनिर्वर्तते । (च० सं० शा० ३/५)
- (इ) न हि केवलं सान्त्वज एवायं गर्भः, समुदायोऽत्र कारणमुच्यते ॥ ११ ॥
- न च केवलं सान्त्वपुत्राणादेव रसानां गर्भाभिनिर्वृतिर्भवति, समुदायोऽत्र कारणमुच्यते ॥ १२ ॥ (च० सं० शा० ३/११ एवं १२)
- (ई) मातुः पितुः आत्मतः सत्वतो रसतः सत्वत इत्येभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भः सम्भवति ॥ (च० सं० शा० ४/४)
३. एवमयं नानाविधानामेषां गर्भकारणं भावानां समुदायादभिनिर्वर्तते गर्भः, यथा-कूटगारां नानाद्रव्यसमुदायान् यथा वा- रथो नानाशङ्कसमुदायान्; तस्मादेतद्वैचाम्-मातृजज्ञाश्च गर्भः, पितृजज्ञः, आत्माजज्ञः, सान्त्वजज्ञः, रसजज्ञः, अस्ति च सत्वमौपपादुकमिति ॥ (च० सं० शा० ३/१४)
४. इह खलु यो मातृजज्ञाश्च गर्भः पितृजज्ञाश्च सान्त्वजज्ञः रसजज्ञः, अस्ति च सत्वमौपपादक (पादु) कर्मित्वायेवचनम् ॥ नेति भट्टनाजः । (अमरु) जज्ञाश्च गर्भः, अपितृजज्ञानात्सत्वज्ञाना(सा)त्म(त्व)जज्ञः, अर(स)जज्ञः, नास्ति च सत्वमौपपादक (पा)दि(दु)कर्मिति ॥ (शे० सं० शा० ६/२, २)

(१) मातृजादि घटकों के स्वतंत्र कारणात्त्व का खण्डन (Contradiction of formation of embryo with maternal etc. singular component.)

(अ) गर्भोत्पत्ति में केवल माता एवं पिता के कारणात्त्व का खण्डन (Contradiction of only mother and father as factors for embryogenesis)

यदा हि मातापितरौ गर्भं जनयेतां, भूयस्यः स्त्रियः पुमांसश्च भूयोसः पुत्रकामाः, ते सर्वे पुत्रजन्ममिसम्भाव्य भैशुनधर्ममप्यध्यामानाः पुत्रानेव जन्मेयुर्द्विहितर्वा दुहितुकामाः, न तु काश्चित् स्त्रियः केचिद्धा पुरुषा निरपत्याः स्वरूपत्वकामा वा परिदेवेरन् । (च० सं० शा० ३/३ (२))

यदि केवल माता और पिता ही गर्भोत्पत्तिक माने जायें, तो पुत्रकांक्षी बहुत से युग्म पुत्र-प्राप्ति के लिए भैशुन में प्रवृत्त होकर केवल पुत्र ही उत्पन्न करेंगे, इसी प्रकार कन्याार्थी कन्याएँ। एवं कोई भी स्त्री एवं पुरुष सन्तानविहीन नहीं रहेंगे और सन्तान के लिए कोई दुखी भी न होंगे।

महर्षि भेल ने भी चरक के सदृश ही माता के कारणात्त्व का खण्डन किया है कि यदि केवल वह स्वयं ही पुत्रोत्पादक है तो भैशुन में प्रवृत्त होकर इच्छानुसार ही पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर सकती है।^१

If only mother and father are responsible or are capable of producing an embryo then various couples desirous of having only male children will indulge in copulation and produce only male children, similarly others may produce only girls. Neither of the couple will remain childless or be sorry for not having child of wanted sex (but it is not seen in practice or only mother and father are not capable of producing the embryo).

(आ) गर्भोत्पत्ति में केवल आत्मा के कारणात्त्व का खण्डन (Contradiction of only ātma as a factor for embryogenesis)

न चात्माऽन्मानं जनयति । यदि ह्यात्माऽन्मानं जनयेज्जातो वा जनयेदात्मानजतो वा, तत्त्वोभयशऽप्ययुक्तम् । न हि जातो जनयति सत्त्वात्, न जाजतो जनयत्यसत्त्वात्, तस्मादुभयशऽप्यनुपपत्तिः । तिष्ठतु तावदेतत् । यद्ययमात्माऽन्मानं शक्तो जनयितुं स्यात्, न त्वेनामिष्टास्त्वेव कथं योनिषु जन्मेद्विशिनमप्रतिहतमिति कामरूपिणं तेजोबलजववर्णसत्त्वसहंनममुदितमजरमरुजन्ममरुः, एवमिदं ह्यात्माऽन्मानमिच्छत्यतो वा भूयः ॥

(च० सं० शा० ३/३ (३))

आत्मा कभी भी आत्मा को उत्पन्न नहीं करता, यदि आत्मा से ही गर्भोत्पत्ति मानी जाय, तो गर्भ जात (उत्पन्न) या अजात (अनुरूप) किस आत्मा से उत्पन्न होता है (यह प्रश्न होगा) ? ये दोनों ही बातें अयुक्त (युक्तिसंगत नहीं) हैं, क्योंकि जात आत्मा वर्तमान होने के कारण गर्भ को उत्पन्न नहीं कर सकता, एवं अनुरूप गर्भोत्पादक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो है ही नहीं^२ अतः यह दोनों प्रकार से आत्मा उत्पादन में असमर्थ है। यदि आत्मा को आत्मा का उत्पादक मान भी लिया जाय, तो वह आत्मा अपनी इष्ट योनियों में ही क्यों नहीं जन्म लेती, क्योंकि आत्मा वशी (स्वयं के ही केवल वश में), अप्रतिहत गति (बाधा रहित गति वाली), कामरूपी (स्वेच्छानुसार रूपधारी), तेज, बल, वेग, वर्ण, सत्व एवं संहनन से युक्त, अजर, रज्जा-रहित एवं अमर आदि गुणों से युक्त है, एवं (उत्पन्न) गर्भ को भी अपने ही (इना उपर्युक्त)

(शे० सं० शा० ६/२)

१. यदा हि मात पुत्रं जनयेदप्युच्छिष्टं हि स्त्री पुत्रकामा भैशुनधर्ममिसम्भाव्य पुत्रं जनयेत् स्त्रीकामा च (स्त्रीवा) ॥
२. सत्त्वादिति जन्मस्यात्मनो विद्यमानत्वात्, न च विद्यमानो जन्मत इत्यर्थः । असत्त्वादिति कारणभूतस्यात्मनोऽसत्त्वात् कारणात्त्वपुष्यमित्यर्थः ॥ (च० सं० शा० ३/३ (३) की चक्र० टी०)

गुणों से युक्त या इन (गुणों) से भी उत्पन्न (गुण वाला) देखना चाहती है (पर ऐसा प्रयत्न में नहीं देखा जाता अर्थात् योनि में जन्म एवं गुणोत्पत्ति स्वेच्छाधीन नहीं होता, अतः केवल आत्मा ही गर्भोत्पादक है ऐसा नहीं मान सकते)।

Ātma never produces another *ātma*. If embryo is accepted to be formed only from *ātma*, then the questions would come up that to which *ātma*, born or unborn, both these do not stand the test of logic, because the born *ātma* can not produce embryo, since it is already present, and unborn *ātma* also can not be considered since it is nonexistent, thus *ātma* of both these types is incapable of producing the embryo. Even if *ātma* is accepted as creator of another *ātma* then the question will come why it does not take birth in the species of its choice? *Ātma* is under its own control, has unrestricted movement, can acquire desired appearance, possesses *teja* (sharpness), *vega* (momentum), *bala* (power), *varṇa* (complexion or character), *saṁhānana* (compactness) and *śatva* (mind or strength of character), and is undecaying or ever young, free from diseases and is immortal. It would have preferred to transmit these very qualities or even better ones in embryo (but it is not seen, birth in specific species and possession of qualities does not depend on its own will, thus only *ātma* is not capable of producing *garbhā*).

(इ) गर्भोत्पत्ति में केवल सात्व्य के कारणत्व का खण्डन (*Contradiction of only sāmya as a factor for embryogenesis*)

असात्व्यज्ञातं गर्भः। यदि हि सात्व्यज्ञः स्यात्, तर्हि सात्व्यसेविनामेवकान्तेन प्रजा स्यात्; असात्व्यसेविनाश्च निखिलेनानपत्याः स्युः, तत्त्वोभयपुम्भयवैव दृश्यते ॥ (च० सं० शां० ३/३ (४))

गर्भ केवल सात्व्य से ही उत्पन्न नहीं होता। यदि यह सात्व्यज्ञ होता तो केवल सात्व्यसेवी (दम्पति) को ही सन्तति उत्पन्न होती। सभी असात्व्यसेवी (दम्पति) अनपत्य हो होते, पर दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा नहीं देखा जाता (अर्थात् सात्व्यसेवी भी अनपत्य एवं असात्व्यसेवी भी पुत्रवन्त होते देखे गए हैं, अतः गर्भ केवल सात्व्य ही नहीं है)।

Embryo is not derived only from congenial. wholesome or suitable diet. If it was so, then only those couples using above type of diet would have had progeny and the couples consuming non-congenial diet would have been barren, but it is not seen. In both the groups both the conditions exist (couples using congenial diet are found barren while using non-congenial as fertile, thus only congenial diet can not form the embryo).

(ई) गर्भोत्पत्ति में केवल रस के कारणत्व का खण्डन (*Contradiction of only rasa as a factor for embryogenesis*)

अरसज्ञातं गर्भः। यदि हि रसज्ञः स्यात्, न केचित् स्त्रीपुरुषेभ्यनपत्याः स्युः, न हि कश्चिदरस्येषां यो रसाज्ञोपयुङ्क्ते (उपयुङ्क्ते-शु० पा०) श्रेष्ठरसोपयोगिनां चेद्गर्भो जायत इत्यभिप्रेतमिति; एवं सत्याजौरभ-मार्गमायुरगोक्षीरतद्विषमयुलैलैस्त्वेष्वक्षरसमुपगृह्णातिभूतानामेवकान्तेन प्रजा स्यात्, श्यामाककरकोवैलककोरदूध-कन्दमूलभक्षश्च निखिलेनानपत्याः स्युः, तत्त्वोभयपुम्भयव दृश्यते ॥ (च० सं० शां० ३/३ (५))

केवल रस से ही गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। यदि केवल रस से ही गर्भोत्पत्ति होती तो कोई भी स्त्री-पुरुष सन्तान-रहित न होते, क्योंकि इनमें से (स्त्री-पुरुष में से) ऐसे कोई भी नहीं हैं जो रस का सेवन नहीं करते। एवं रस से ही गर्भोत्पत्ति होने पर केवल श्रेष्ठ रसोपयोगी ही संतानयुक्त होते जैसे बकरा, भेड़, मृग एवं मायूर के मांसरस, गोदूध, दधि,

घृत, मधु, तैल, सैन्धव, इक्षुरस, मुद्गरा एवं शालि-चावल आदि सेवन करने वालों को ही सन्तान उत्पन्न होती। श्यामा (साँव), ककरक, उद्दालक (बनकोटी), कोरदूध (कोटी) एवं कन्दमूल आदि खाने वाले सभी सन्तान रहित होते, पर दोनों ही स्थितियों में ऐसा नहीं होता (अर्थात् गोदूधदि सेवी संतान-रिहीन एवं उद्दालकादि सेवी भी सन्तान वाले देखे जाते हैं, अतः गर्भ केवल रस ही नहीं है)।

Only *rasa* is not capable of producing embryo. If only *rasa* was responsible then no couple would have remained barren, because there is none who does not use *rasas*. However, if *rasa* was exclusive factor, then only the couples using substances possessing high quality of *rasa* i. e. gravy of goat, sheep, deer and peacock etc., cow's milk, curd, *ghee*, honey, oil, rocksalt, cane-juice, *mudga* (green gram) and *śāli* (specific rice) will bear the children. Others using *śyāmā*, *kavarakā*, *uddālaka*, *koradūya* (all different types of millets) and bulbous or tuberos roots will become infertile, which is not so. (The persons consuming both types of diets are found barren or fertile, or *rasa* exclusively can not produce *garbhā*).

(उ) गर्भोत्पत्ति में केवल सत्व के कारणत्व का खण्डन (*Contradiction of only satva as a factor for embryogenesis*)

न खल्वपि परलोकादेव सत्त्वं गर्भमवक्रामति; यदि हेनमवक्रामते, नास्य किञ्चित् पौर्वेदिकं स्यादविदितमभ्युत्पद्यद्वा, स च तच्च न किञ्चिदपि स्मरति ॥ (च० सं० शां० ३/३ (६))

परलोक से आकर सत्त्व गर्भ में अवक्रमण नहीं करता, यदि यह सत्त्व परलोक से आकर अवक्रमण करता तो पूर्वजन्म की कोई भी बात (इस मन को) अज्ञात, अश्रुत या अदृष्ट न रहती (क्योंकि मन ही इन्द्रियों से संयोग होने पर ज्ञान करता है अतः मन को पूर्व जन्म की सभी बातों का ज्ञान रहता), परन्तु ऐसा नहीं होता, पूर्वजन्म की किसी भी बात का (बालक को) स्मरण नहीं रहता (अतः केवल सत्त्व ही गर्भ का कारण नहीं हो सकता)।

The *satva* does not descend from outer world, if it was so, then all the happenings of previous life would not have remained unknown, unheard or unseen (because it is *mana*, association of which with sensory organs is essential for acquiring the knowledge and it would have remembered those things even after separation from the body, thus would have carried to the next life), but it is not seen, one does not remember anything of the previous life (thus *satva* can not be the exclusive factor for formation of *garbhā*).

(२) गर्भोत्पत्ति में मातृजाति भावों की कारणता एवं उनसे उत्पन्न अङ्ग (The Importance of all mother etc. six factors in the formation of embryo and various body parts derived from these)

(अ१) गर्भोत्पत्ति में माता की कारणता (*Mother as a factor in embryogenesis*)

मातृजात्याय गर्भः। न हि मातृविना गर्भोत्पत्तिः स्यात्, न च जन्म जरायुजानाम् ॥ (च० सं० शां० ३/६)

यह गर्भ माता से उत्पन्न होता है। माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जरायुज योनि के प्राणियों का जन्म माता के बिना नहीं हो सकता।

The embryo is born from the mother. Birth in the species having placentaion (*jarayuja*) is not possible without mother.

(अ२) गर्भ के मातृज भाव या अङ्गावयव (*Fetal parts derived from the mother*)

यानि खल्वस्य गर्भस्य मातृजानि, यानि चास्य मातृतः सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः; तद्यथा त्वक् च लोहितं च मांसं च मेदश्च नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च वसिष्ठश्च पुरीषाधानं चामाशयश्च यकाशयश्चेत्तरुदं चाधरुदं च क्षुद्रान्नं च स्थूलान्नं च वषा च वषावहनं चेति (मातृजानि) ।

(च० सं० शा० ३/६)

मांसशोणितमेदोमज्जहृत्नाभिचयकृत्प्लीहान्नगुरुधृतीनि मूदूनि मातृजानि॥ (सु० सं० शा० ३/३३)

तेषु मातृजानि मूदूनि त्वप्रक्तमांसमेदोमज्जनाभिहृदयामाशयाधरुदयकृत्प्लीहक्लोमन्नगुदादीनि॥

(अ० सं० शा० ५/१४)

मूद्वजं 'मातृजं' रक्तमांसमज्जगुदादिकम् ॥ (अ० ह० शा० ३/४)

लोहितं च मांसं च नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च वसिष्ठश्च पुरीषाधानं चामाशयश्चेत्तरुदश्च क्षुद्रान्नं च स्थूलान्नं चेति मातृजानि॥ (का० सं० शा० ३/४)

महर्षि चरक कहते हैं कि गर्भ के जो मातृज अवयव हैं, या जो अङ्ग गर्भ के उत्पन्न होते समय माता से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है जैसे-त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वसिष्ठ, पुरीषाधान (मलाशय), अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधोगुद, क्षुद्रान्न, स्थूलान्न, वषा तथा वषावहन मातृज अङ्गावयव हैं ।

महर्षि सुश्रुत के अनुसार मांस, शोणित, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, अन्न, गुदा प्रभृति मूदु अङ्ग मातृज हैं ।

सभी मूदु अङ्ग जैसे त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, नाभि, हृदय, अमाशय, गर्भाशय, यकृत, प्लीहा, क्लोम, आंत्र एवं गुदा आदि अष्टांगसंग्रहोक्त मातृज अवयव हैं । अन्तर्ग नेत्र के कृष्णमण्डल को भी रक्त से उत्पन्न होने के कारण मातृज अङ्ग माना है ।^१

अष्टांगहृदयकार ने संक्षेप में रक्त, मांस, मज्जा, गुदादि मूदु अङ्गों को मातृज गिनाया है । टीकाकार अरुणदत्त ने आदि शब्द से नाभि, यकृत, हृदय, प्लीहा, अमाशय आदि का ग्रहण किया है ।^१

महर्षि काश्यप ने उपर्युक्त वर्णन के सदृश ही रक्त, मांस, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वसिष्ठ, पुरीषाधारण (मलाशय), अमाशय, उत्तरगुद, क्षुद्रान्न, स्थूलान्न आदि अङ्गों को मातृज वर्णित किया है ।

आचार्य भवमिश्र ने भी महर्षि सुश्रुत के सदृश ही मांस, रक्तदि अङ्गों को मातृज माना है ।^३

All the soft structures are derived from the mother such as—

Body parts	CS	SS	KS	AS	AH	BP
Skin	+	—	—	+	—	—
Blood	+	+	+	+	+	+
Muscles	+	+	+	+	+	+
Fat	+	+	—	+	—	+
					cont.	

१. असुबः कृष्णमण्डलं तन्मातृजं । (अ० सं० शा० ५/५१)

२. आदि शब्देन नाभिहृदययकृत्प्लीहामाशयादीनां ग्रहणम् ॥ (अ० ह० शा० ३/४ की अरुण० टी०)

३. मांससूक्ष्मजमेदांसि यकृत्प्लीहान्नानाधमः । हृदयं च गुदं चापि भवन्त्येतानि मातृजः॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३१७)

Body parts	CS	SS	KS	AS	AH	BP
Umbilicus	+	+	+	+	+++	—
Heart	+	+	+	+	+++	+
Pancreas (<i>kloma</i>)	+	—	+	+	+++	—
Liver	+	+	+	+	+++	+
Spleen	+	+	+	+	+++	+
Kidney	+	—	+	+	—	—
Urinary bladder	+	—	+	+	—	—
Rectum	+	—	+	+	—	—
Stomach	+	—	+	+	+++	—
Upper part of rectum	+	++	+	+	++	++
Lower part of rectum	+	++	—	+	++	++
Small intestine	+	++	+	+	++	++
Large intestine	+	++	+	+	++	++
Bone marrow	—	+	—	+	+	+

*The arthors have described only *guda* (anus) and *āntra* (intestines).

**Mentioned by Arunadatta.

Besides these, Caraka has included *pakwāḍya* (duodenum), *vapā* (omentum) and *vapāvahana* (omentum sac) and *Vāḍephata* I, the uterus in the list, he says further that *kṛṣṇamāṇḍala* (cornea) of eye having developed from blood is also an organ derived from mother.

(आ १.) गर्भोत्पत्ति में पिता की कारणात्ता (*Father as a factor in embryogenesis*)

पितृजश्रयं गर्भः । न हि पितृकृते गर्भोत्पत्तिः स्यात्, न च जन्म जरायुजानाम् ॥

(च० सं० शा० ३/७)

यह गर्भ पितृज है, बिना पिता के गर्भोत्पत्ति नहीं हो सकती, जरायुज प्राणियों का जन्म पिता के बिना नहीं हो सकता।

The species having placentalation (*jaṛayujā*) can not get birth without father.

(आ २.) गर्भ के पितृज भाव या अङ्गावयव (*Body parts derived from the father*)

यानि खल्वस्य गर्भस्य पितृजानि, यानि चास्य पितृतः सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः; तद्यथा केशशमभ्रुनखलोमेदन्तास्थिसिरान्नायुधमन्यः शुक्रं चेति (पितृजानि) ॥ (च० सं० शा० ३/७)

गर्भस्य केशशमभ्रुनखलोमेदन्तास्थिरान्नायुधमनीलः प्रभृतीनि स्थिराणि पितृजानि ॥

(सु० सं० शा० ३/३३)

पितृजानि स्थिराणि केशनखास्थिशुक्रसिरान्नायुधदीनि ॥ (अ० सं० शा० ५/१५)

‘पैतृकं’ तु स्थिरं शुक्रधमन्यस्थिकयादिकम् ॥ (अ० ह० शा० ३/५)

केशाश्च रोमाणि च श्मश्रूणि च नखाश्च दन्ताश्चास्थीनि च सिराश्च न्नायवश्च धमन्यश्च शुक्रं चेति पितृजानि ॥

(का० सं० शा० ३/४)

महर्षि चरक लिखते हैं, कि इस गर्भ के जो पितृज अंग हैं, या गर्भोत्पत्ति के समय जो पिता से उत्पन्न होते हैं,

उनकी व्याख्या की जाती है, जैसे-केश, समुद्र, नद्य, ताम्र, दन्त, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी एवं शुक्र आदि पितृज अंगावयव है।

महर्षि सुश्रुत ने अक्षरशः वही अंग गिना है जो चरक ने जैसे-केश, समुद्र, लोम, अस्थि, नख, दन्त, सिरा, स्नायु, धमनी, रेत (शुक्र) एवं अन्य स्थिर अंगावयव पितृज माने हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने केश, नख, अस्थि, शुक्र, सिरा, स्नायु आदि सभी स्थिर अंगावयव पितृज माने हैं अन्यत्र कफ-प्रसव से उत्पन्न नेत्र के शुक्लमण्डल को भी पितृज अङ्ग माना है।^१

स्थिर अंग एवं शुक्र, धमनी, अस्थि, केशादि अंग अष्टाङ्गहृदयोक्त पितृज भाव है। टीकाकार अरुणदत्त ने आदि शब्द से सिरा, स्नायु, रेत आदि का ग्रहण किया है।^२

महर्षि भावमिश्र ने भी अस्थि के अतिरिक्त अन्य उपर्युक्त अङ्गों का ही इस वर्ग में वर्णन किया है।^३

All stable or hard structures are derived from the father.

Body parts	CS	SS	AS	AH	KS	BP
Hair (scalp)	+	+	+	+	+	+
Beard and moustache	+	+	—	—	+	+
Hair of body	+	+	—	+	+	+
Teeth	+	+	—	—	+	+
Bones	+	+	+	+	+	—
Veins	+	+	+	+	+	+
Tendons	+	+	+	+	+	+
Arteries	+	+	—	+	+	+
Semen	+	+	+	+	+	+
Nail	+	+	+	—	+	+

*Mentioned by Arunadatta

Besides above, Vāgbhata I has included *śuklamandala* (sclera) of eyes born from essence of *kapha* also under this category.

विमर्श (Comments)

गर्भ के निर्मलत सभी वटकों में जंगर के विभिन्न रचनात्मक अङ्गों की निर्मिति मातृज एवं पितृज भावों से ही होती है। यद्यपि इन दोनों भावों से निर्मित अङ्गों का सुस्पष्ट सामञ्जस्य आधुनिक विज्ञान में वर्णित गर्भ के विभिन्न स्तरों (एक्टो, एन्डो तथा मेसेन्डो-म) द्वारा निर्मित अङ्गों से नहीं हो सकता फिर भी अधिकांश पितृज अंग एक्टो-म से निर्मित तथा मातृज अंग एन्डो एवं मेसेन्डो-म से निर्मित प्रतीत होते हैं।

१. वैद्यपि च नेत्रे श्लेष्माणः प्रसदाच्छुक्रमण्डलं तद्विपुलम्॥ (अ० सं० शा० ५/५१)

२. आदि शब्देन शिराज्जायुर्मादीनां ग्रहणम्। (अ० ह० शा० ३/५ की अरुण० टीका)

३. केशाः समुद्र च लोमानि नद्या दन्ताः शिरास्तथा। धमन्यः स्नायवः शुक्रमेतानि पितृजाणि हि॥ (भा प्र पूर्व० ३/३१६)

All the physical components of fetus are derived from mother and father. Though it is difficult to equate any specific structure of embryo resembling with these maternal or paternal factors, however, most of the paternal organs seem to be ectodermal, while maternal endo or mesodermal.

(इ १) गर्भोत्पत्ति में कर्म की प्रधानता होते हुए भी आत्मा का महत्त्व (Importance of ātmā as a factor in embryogenesis)

न खलु गर्भस्य न च मातुर्न पितुर्न चात्मनः सर्वभावेषु यथेष्टकारित्वमस्ति; ते किञ्चित् स्ववशात् कुर्वन्ति, किञ्चित् कर्मवशात्, क्वचिच्चैषां कारणशक्तिर्भवति, क्वचिन्न भवति। यत्र सत्त्वादिकरणसंपन्नत्र यथाबलमेव यथेष्टकारित्वम्, अतोऽप्यथा विपर्ययः। न च कारणदोषादकारणमात्मा संभवति गर्भजनने, दृढं चेष्टा योनिरैश्वर्यं मोक्षश्चात्मविद्विषायात्म्यम्। न ह्यन्यः सुखदुःखयोः कर्ता। न चाप्यतो गर्भो जायते जायमानः, नाङ्गुरोत्पत्तिर्बीजात्।
(च० सं० शा० ३/१९)

गर्भोत्पत्ति के सभी भावों में माता, पिता या आत्मा को स्वेच्छाचारिता नहीं होती। ये भाव कुछ कार्य अपने वश में होकर, कुछ कर्म के वशीभूत होकर करते हैं। कहीं-कहीं इनके कारण (मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि) शक्ति (समर्थ) होते हैं और कहीं नहीं होते। जब सत्त्व आदि कारण प्रकृत होते, वहाँ उनके बल के अनुसार कर्म-सामर्थ्य होगा अन्यथा विपर्यय होगा। किन्तु कारण में दोष होने पर आत्मा गर्भ की उत्पत्ति में अकारण नहीं होता अर्थात् गर्भ की उत्पत्ति के प्रति उसकी कारणता भङ्ग नहीं होती। क्योंकि आत्मा के जानने वाले व्यक्तियों ने यह देखा है कि अभीष्ट योनि, ऐश्वर्य एवं मोक्ष आत्मा के आधीन हैं। आत्मा के अतिरिक्त सुख-दुःख का कर्ता कोई अन्य नहीं है। उत्पन्न होता हुआ गर्भ आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती (अर्थात् अत्मा ही गर्भ का मूल या बीज कारण है, इसके बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती)।

The mother, father and ātmā etc. factors are not totally independent for all their functions. By these factors some of the functions are performed independently, some depending upon the deeds (of previous life) and some upon the *karma* (means of actions or instruments i.e. *mana*, *buddhi* and *indriyas*). At some places these instruments are much potent and at others not so. When these *satwa* etc. instruments are normal, their functional capacity will depend upon their relative strength, otherwise not (if these are abnormal, their functional capacity will alter). However, in case of abnormality of these instruments the ātmā does not become non-causative in the process of formation of *garbha* or in other words its causativeness for formation of embryo does not break, because the persons knowing ātmā have observed that birth in desired species, supremacy (*aiswarya*) and eternal emancipation depend upon ātmā. There is none other than ātmā responsible for giving feeling of pleasure and pain. As a sprout can not come up without seed, similarly birth can not take place without ātmā or in other words root cause of *garbha* is ātmā without this the formation of embryo is impossible.

(इ २) गर्भ के आत्मज भाव (Features developing from ātmā)

यानि तु खल्वस्य गर्भस्यात्मजानि, यानि चास्यात्मतः संभवन्ति, तावन्नुपस्थाध्याय्यामः, तदथा-तासु तासु योनिसूचितासुतात्मजानं मन इन्द्रियाणि प्राणायानौ प्रेरणं धारणमाकर्तित्स्वरवर्णविशेषाः सुखदुःखे इच्छाद्वेषो वेतना धृतिर्बुद्धिः स्मृतिर्हङ्कारः प्रयत्नश्चेति (आत्मजानि)। (च० सं० शा० ३/१०)

इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः सुखदुःखदिकं च आत्मजानि ॥ (सु० सं० शा० ३/३३)

आत्मजानि तासु तासु योनिभूयन्तिर्मनश्चेतोन्द्रियाणि प्राणपानौ धारणामकृतिस्वरवर्णविशेषाः कामक्रोधलोभ-
मदहर्षाः धर्माधर्मशीलतास्मृतिबुद्धीच्छाद्वेषप्रयत्नाहङ्कारसुखदुःखायुरात्मजानि च । (अ० सं० शा० ५/१६)

‘चैतनं’ चित्तमक्षाणि नानायोगिषु जन्म च ॥ (अ० ह० शा० ३/५)

आयुश्चात्मज्ञानं च मनश्चेन्द्रियाणि च प्राणपानौ च धारणं च प्रेरणं च चाकृतिश्च स्वरवर्णोपवयविशेषाश्च
सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ च स्मृतिश्चाहङ्कारश्च प्रयत्नश्चस्वान्तरगमनं च मत्त्वं च नानायोगिषूपपत्तिश्चेत्यात्मजानि ॥
(का० सं० शा० ३/४)

महर्षि चरक लिखते हैं कि अब गर्भ के जो आत्मज भाव हैं या गर्भोत्पत्ति के समय जो जो भाव आत्मा से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है, जैसे-उस उस विशिष्ट योनि में उत्पत्ति, आयु (उत्तम, मध्यम या हीन आयु होना), अन्तर्ज्ञान, मन, इन्द्रियाँ, प्राणपान, प्रेरण, धारण, आकृति, स्वर, विशिष्ट वर्ण, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति (धारणशक्ति), बुद्धि (ज्ञानशक्ति), स्मृति, अहंकार, प्रयत्न आदि आत्मज भाव हैं ।

अन्य महर्षि चरक ने लिखा है कि जो प्रयोका है अर्थात् आत्मा है वही बुद्धि एवं मन के साथ प्रधान है ।
महर्षि सुश्रुत ने इन्द्रियों का ज्ञान एवं विज्ञान, आयु, सुख एवं दुःखादि को आत्मज भाव माना है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार लिखते हैं कि उन विशिष्ट योनियों में उत्पत्ति, मन, चेतना, इन्द्रियाँ, प्राणपान, धारण^१ (उत्साह), विशिष्ट आकृति, स्वर एवं वर्ण, काम, क्रोध, लोभ, भय, हर्ष, धर्माधर्मशीलता, स्मृति, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, अहंकार, सुख, दुःख, आयु एवं आत्मज्ञान आदि गर्भ के आत्मज भाव हैं ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने चित्त, इन्द्रियाँ एवं नाना योनि में जन्म आदि आत्मज भाव माने हैं । टीकाकार अरुणदत्त ने उपर्युक्त को उत्तरक्षण मात्र मानकर काम, क्रोध, लोभ, भय, हर्ष, धर्माधर्मशीलता, स्मृति, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, अहंकार, सुख, दुःख, आयु एवं विशिष्ट स्वर आदि को भी चेतना-जन्म माना है ।

महर्षि काश्यप के मत से आयु, अन्तर्ज्ञान, मन, इन्द्रियाँ, प्राण-अपान का धारण एवं प्रेरण, आकृति, विशिष्ट स्वर एवं वर्ण का उपचय, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, अवस्थान्तरगमन, सत्त्व एवं नाना योनियों में उत्पत्ति आदि आत्मज भाव हैं ।

आचार्य भास्विमिश्र ने भी उपर्युक्त वर्णन सदृश ही ज्ञान, विज्ञान आदि को आत्मज माना है ।^४

The features derived from *aima* are :

Features	CS	SS	AS	AH	KS
Birth in specific species	+	—	+	+	+
Knowledge about oneself	+	—	+	—	+
<i>Mana</i>	+	—	+	—	+
					cont. ...

१. यत् प्रयोक्तुं तत् प्रधानं बुद्धिर्मनश्च ॥ (च० सं० शा० ७/१६)

२. धारणमवयवनां धारणमुत्साहेन देहाव्ययमः ॥ (अ० सं० शा० ५/१६ को इन्द्र टीका)

३. उपलक्ष्यं चेदम् कामक्रोधलोभमदहर्षधर्माधर्मशीलतास्मृतिबुद्धीच्छाद्वेषप्रयत्नाहङ्कारसुखदुःखायुःस्वरविशेषादयोऽपि हि चैतना एव ॥ (अ० ह० शा० ३/५ को अरुण टीका)

४. ज्ञानं विज्ञानमायुश्च सुखदुःखदिकं तथा । इन्द्रियाणि च सर्वाणि भवन्त्येतानि चात्मनः ॥
(सुख) दुःखादिकमित्यादिश्च नानायोगिजन्मादिकमुच्यते ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३१९)

Features	CS	SS	AS	AH	KS
Respiration and Flatus	+	—	+	—	+
Impulse	+	—	—	—	+
Sustenance	+	—	+	—	+
Appearance	+	—	+	—	+
Voice	+	—	+	+	+
Specific complexion	+	—	+	—	+
Happiness and sorrow	+	+	+	+	+
Lounging and hatred	+	—	+	+	+
Consciousness	+	—	+	+	—
<i>Dhriti</i> (retention power)	+	—	+	—	—
<i>Buddhi</i> (knowledge)	+	—	+	+	—
<i>Smriti</i> (memory)	+	—	+	+	+
Pride or egotism	+	—	+	+	+
Endeavour	+	—	+	+	+
Longevity	—	+	—	+	+
Perception of <i>indriyas</i>	—	+	+	+	+

*Mentioned by Arunadatta.

Bhāvamiśra has followed Suśruta with the addition of birth in specific species. Besides above features Vāgbhata I and Arunadatta have enumerated sexual desire, anger, greed, fear, excitement, virtuous disposition and unrighteousness or unvirtuousness and Kāśyapa has mentioned transition in different stages and *sarwa* (spiritual essence) in the list.

(ई १) गर्भ की उत्पत्ति में सारस्य की कारणात्ता (*Sāmya as a factor in embryogenesis*)

सारस्यजश्चायं गर्भः । नष्टासारस्यसेविलम्बनेण स्त्रीपुरुषयोर्वन्धव्यत्वमस्ति, गर्भेषु वाऽप्यनिष्ठो भावः । यावत् खल्वसारस्यसेविनां स्त्रीपुरुषाणां त्रयो दोषाः प्रकृतिताः शरीरमुपसर्पन्तो न शुक्रशोणितगर्भाशयोपघातायोपघ्नन्ते, तावत् समर्थ गर्भजननाय भवन्ति । सारस्यसेविनां पुनः स्त्रीपुरुषाणामनुपहतशुक्रशोणितगर्भाशयानामुत्पत्तिकाले सञ्चयितानां जीवस्यानवकमणार्द्रगर्भं न प्रादुर्भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ३/१११)

यह गर्भ सारस्यज है क्योंकि बिना असारस्य सेवन के स्त्री-पुरुष वन्ध नहीं होते, और न ही गर्भ का कोई अनिष्ट (विकृति) ही होता है (अर्थात् गर्भ-विकृति एवं वन्धव्यत्व असारस्य प्रयोग-जन्म होते हैं) । जब तक असारस्य का सेवन करने वाले स्त्री-पुरुष के प्रकृतिगत हुए तीनों दोष शरीर में उपसर्पण करते हुए शोणित-शुक्र एवं गर्भाशय को दूषित नहीं करते, तब तक वे स्त्री-पुरुष गर्भोत्पन्न में समर्थ होते हैं (अर्थात् असारस्य सेवन से जब शुक्र-शोणित या गर्भाशय दूष्ट होंगे तभी गर्भोत्पन्न में असमर्थता होती है अन्यथा नहीं) । अतिकृत शुक्र, शोणित एवं गर्भाशय वाले सारस्यसेवी पुरुष-स्त्री द्वारा ऋतुकाल में संयोग करने पर भी जीव के अवकमण न करने से गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् जीव के अवतरण होने पर ही गर्भधान होता है ।

The *sāmya* is important for conception. Without use of noncongenial articles neither the couple is sterile nor fetus has any abnormalities. Till the *dōṣas* getting vitiated due to

the use of noncongenital article and spreading through body do not vitiate sperms, ovum and uterus, the couple can achieve conception. The couple possessing healthy sperms, ovum and uterus, consuming only congenital articles and copulating during fertile period (*utrikālā*) will not achieve conception if the *jīva* (life or soul) does not descend. In other words the conception will result only after descent of *jīva*.

(ई २) गर्भ के सात्म्य भाव (*Features developing from sāmya*)

यानि खल्वस्य गर्भस्य सात्म्यजानि, यानि चास्य सात्म्यतः संभवन्ति, तान्युव्याख्यास्यामः; तद्यथा- आरोग्यमनालस्यमनोलुपत्वमिन्द्रियग्रामादः स्वरवर्णबीजसम्पत् प्रहर्षभूयस्त्वं चेति (सात्म्यजानि)।

(चं मं शां ३/११)

वीर्यमोग्यं यलवर्णं मेधा च सात्म्यजानि ॥ (सु० सं० शां ३/३३)

सात्म्यज्ञान्यायोग्यमनालस्यमनोलुपत्वमिन्द्रियग्रामादस्वरवर्णबीजः सम्पद्यशस्तताः प्रहर्षभूयस्त्वं मेधाबलं च ॥ (अ० सं० शां ५/१७)

'सात्म्यं' त्वायुस्योग्यमनालस्यं प्रभा बलं ॥ (अ० हं शा ३/६)

आरोग्यं चोद्यतं च संतोषोऽन्द्रियग्रामादश्च स्वरवर्णबीजसम्पत् मेधा च प्रहर्षभूयिष्ठता चेति सात्म्यजानि ॥

(का० सं० शां ३/४)

महर्षि चरकः निश्चयेन है कि जो गर्भ के सात्म्य भाव है या जो भाव गर्भोत्पत्ति के समय सात्म्य से उत्पन्न होते हैं उनको व्याख्या की जाती है, जैसे- आरोग्य, अनालस्य (उत्साह या कार्यशक्ति), अलोत्पल, इन्द्रियप्रसाद, स्वर, वर्ण एवं बीज का सम्पत् (शुद्ध) होना तथा सदा आनन्द की अधिकता होना आदि सात्म्य भाव हैं।

वीर्य, आरोग्य, वनः वर्ण एवं मेधादि भाव महर्षि सुश्रुत के मत से सात्म्य भाव हैं।

अष्टाङ्गसंग्रह-मननुसर आयु, आरोग्य, अनालस्य, अलोत्पल, इन्द्रियप्रसाद, स्वर, वर्ण, वीर्य एवं बीज का सम्पत् (शुद्ध) एवं प्रगल्भ (अष्ट) होना, सदा आनन्दविरिक, मेधा एवं बल आदि सात्म्य भाव हैं।

अष्टाङ्गहृदयत्रय ने आयु, आरोग्य (भाव-सात्म्य), अनालस्य (उत्साह), प्रभा (कान्ति) एवं बल (शक्ति) को सात्म्य भाव माना है। टीकाकार अरुणदत्त ने तीन प्रकार के सात्म्य (व्याधि, देश एवं देह) में से यहाँ पर देश एवं देह सात्म्य को ही प्राधान्य माना है तथा उपर्युक्त गुणों को उपलक्षण मात्र मानकर अलोत्पल, इन्द्रिय-प्रसाद, स्वर, वर्ण, वीर्य एवं बीज को सम्पत्ता तथा प्रहर्ष आदि को भी सात्म्य माना है।^१

आरोग्य, उत्पल (उज्ज्वलि), संतोष, इन्द्रिय-प्रसाद, स्वर, वर्ण एवं बीज की सम्पत्ता (शुद्धि), मेधा एवं आनन्दविरिक आदि भावों का सात्म्य भावों के अन्तर्गत महर्षि काश्यप ने वर्णन किया है।

Features developing from *sāmya* as given by authors are given hereunder :

Features	CS	SS	AS	AH	KS
Freedom from diseases	+	+	+	+	+

१. सात्म्यं निविष्य, व्याधिसात्म्यं देहसात्म्यं देशसात्म्यं च। तत्रैह व्याधिसात्म्यं न गृह्यते।। तस्माद्देशसात्म्यं देहसात्म्यं च गृह्यते। उत्पलक्षेण चेदम्। अलोत्पलमिन्द्रियग्रामादस्वरवर्णबीजैः सम्पद्यतेर्थादपि हि सात्म्यजमेवा॥ (अ० हं शां ३/६ की अरण्य टी०)

Features	CS	SS	AS	AH	KS
Absence of idleness	+	—	+	+	—
Absence of greed	+	—	+	+	—
Normal voice	+	—	+	+	+
Normal complexion	+	+	+	+	+
Normal seed	+	—	+	+	+
Constant happiness	+	—	+	+	+
Brain	—	+	+	—	+
Perspicuity of <i>indriyas</i>	+	—	+	+	+
High quality of <i>oja</i>	—	—	+	+	—
Longevity	—	—	+	+	—
Strength or energy	—	+	+	+	—

*Mentioned by Arunadatta.

Besides these, *Suśruta* has included vigour or valour, *Vāgubhāṣa* II radiance or splendour and *Kāśyapa* elevation or progress and satisfaction in the list.

(उ १) गर्भोत्पत्ति में रस की कारणात्ता (*Rasa as a factor in embryogenesis*)

रसजश्चयं गर्भः। न हि रसादुते मातुः प्राणवाग्नाऽपि स्यात्, किं पुनर्गर्भजम्। न चैवासम्यगुपपुन्यमाना रसा गर्भमभिनिर्वर्तयन्ति ॥ (चं सं० शां ३/१२)

यह गर्भ रसज है। रस के बिना माता ही जीवित नहीं रह सकती तो गर्भ का जन्म कैसे संभव है। असम्यक् रूप से प्रयुक्त रस गर्भ को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है।

The conception is effected by *rasa*. Without *rasa* even mother can not survive, so the question of conception (without *rasa*) does not arise. Improper utilization of *rasa* can not cause conception.

(उ २) गर्भ के रसज भाव (*Features arising due to rasa*)

यानि तु खल्वस्य गर्भस्य रसजानि, यानि चास्य रसतः संभवन्ति, तान्युव्याख्यास्यामः; तद्यथा- शरीरस्याभिनिर्वृत्तिरभिवृद्धिः प्राणानुबन्धस्तृप्तिः पुष्टिरत्नादश्चेति (रसजानि) ॥ (चं सं० शां ३/१२)

शरीरोपचयो बलं वर्णः स्थितिर्हृत्तिश्च रसजानि ॥ (सु० सं० शां ३/३३)

रसजानि कृत्तस्य देहस्य सधवो वृत्तिर्वृद्धिर्भिरत्नीत्यं पुष्टिरत्नादश्च ॥

(अ० सं० शां ५/१८)

'रसजं' वपुषो जन्म वृत्तिर्वृद्धिरालोकात् ॥ (अ० हं शां ३/६)

शरीराभिनिर्वृत्तिश्च शरीराभिभूद्विद्वश्च प्राणाश्च बन्धश्च वृत्तिश्च पुष्टिशोत्सादश्चेति रसजानि ॥

(का० सं० शां ३/४)

महर्षि चरक के मतानुसार गर्भ के जो रसज भाव हैं या गर्भोत्पत्ति के समय रस से जो जो भाव उत्पन्न होते

हैं उनकी व्याख्या की जाती है जैसे-शरीर की उत्पत्ति या अंग-प्रत्यंग-व्याकृता^१ एवं वृद्धि, शरीर का प्राणों से अनुबन्ध या संबन्ध या बलानुबन्ध, वृत्ति, पुष्टि (उपचय) एवं उत्साह (जन्म) आदि रसज भाव हैं। टीकाकार चक्रपाणि वर्ण को भी रसज मानते हैं।^१

शरीर का उपचय या पुष्टि, बल, वर्ण, स्थिति (स्वास्थ्य), हार्न (अम्लमास्य) प्रभृति महर्षि सुश्रुतेक रसज भाव हैं। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने निम्न रसज भाव वर्णित किये हैं-गर्भ के सम्पूर्ण शरीर की उत्पत्ति, वृत्ति (गर्भ की गर्भाशय में जीविका), वृद्धि (गर्भ की वृद्धि), वृत्ति, अलोलुपता, पुष्टि एवं उत्साह आदि।

सम्पूर्ण शरीर का जन्म, वृत्ति (गर्भ की जीविका), वृद्धि (गर्भ की वृद्धि) एवं अलोलुपता आदि अष्टाङ्गसंग्रहकार के मतानुसार रसज भाव हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने उपर्युक्त गुणों को उदाहरण स्वरूप मानकर उत्साह, पुष्टि एवं वृत्ति को भी रसज माना है।^३

महर्षि काश्यप ने चरकानुसार ही शरीर की उत्पत्ति एवं वृद्धि, प्राण, वृत्ति, पुष्टि एवं उत्साह को रसज माना है।

आचार्य भवमिश्र ने शरीर के उपचय, बल, वर्ण एवं देहास्थिति को रसज भाव माना है।^३

Psychophysical features derived from rasa are :

Features	CS	SS	AS	AH	KS
Origin of body or manifestation of different body parts	+	—	+	+	—
Growth of body	+	+	+	+	+
Attachment of life or strength with body	+	—	—	—	+
Contentment	+	—	+	++	+
Nourishment	+	—	+	++	+
Enthusiasm or zeal	+	—	+	++	—
Energy or strength	—	+	—	—	—
Health	—	+	—	—	—
Unhealthy state	—	+	—	—	—
Complexion	++	+	—	—	—
Maintenance of body	—	—	+	+	+
Non-greediness	—	—	+	+	—

Mentioned by *Arunadatta or **Cakrapāṇi.

Bhāwaprakāśa book has followed Suśruta.

१. अभिनिवृत्तिः अङ्गप्रत्यङ्गव्यकृता। प्राणानुबन्ध इति बलानुबन्धः। पुष्टिः उपचयः..... उत्साहः बलम्। इति शब्दः प्रकारे, तैर्नैव प्रकाराण्यन्यत्रापि वर्णयदीति रसजानीति दर्शयति ॥ (च० सं० शा० ३/१२ की चक्र० टीका)
२. उत्साहणमात्रं चेदम्। उत्साहपुष्टिवृत्त्येवोपि हि रसजा एव। (अ० ह० शा० ३/६ की अरुण० टी०)
३. शरीरोपचयो वर्णो बलं देहास्थितिरस्य। रसादेतानि जायन्ते भिषजो मुनयो जगुः ॥ (शा० प्र० पूर्व० ३/३१८)

विमर्श (Comments)

आत्मज, सात्म्यज एवं रसज भावों का अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं-कहीं पुनरुक्ति दोष है, जैसे आयु को अष्टाङ्गसंग्रहकार ने आत्मज एवं सात्म्यज दोनों ही वर्गों में वर्णित किया है, इसी भाँति स्वर, वर्ण, अलोलुपता आदि भावों का भी दो-दो वर्गों में वर्णन है, इसका कारण संभवतः इन भावों की उत्पत्ति में दोनों ही कारणों की उपस्थिति है जैसे अलोलुपता रसज एवं सात्म्यज दोनों हैं इसी प्रकार स्वर एवं वर्ण की उत्पत्ति आत्मा एवं सात्म्य दोनों से ही होती है आदि।

There is duplication of certain components of body derived from various factors, such as āyū, voice and complexion etc. have been enumerated under ātmā and sāmānya both. It is possible that in the development of these āyū etc. components both factors i.e., ātmā and sāmānya participate.

(ऊ १) गर्भोत्पत्ति में सत्व (मन) की कारणाता (Sattwa or manna as a factor in embryogenesis)

असि खलु सत्त्वमौषपादुकं; यज्जीवं सुक्ष्मरीरेणासिबन्धाति ॥ (च० सं० शा० ३/१३)

सत्त्व निश्चित ही औषपादुक है (अर्थात् पूर्वजन्म के शरीर से संबन्ध करने वाला है), क्योंकि सत्व जीव का सदा स्पर्श करते हुए शरीर से संबन्ध स्थापित करता है (अर्थात् मन के आत्मा के साथ निरन्तर संबन्ध से ही संसार चलता है मन का संबन्ध विच्छेद होने पर आत्मा स्वतन्त्र हो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है)।

Sattwa is definitely self-produced or has relation with the body of previous life. The sattwa being constantly associated with jīva establishes link with the present body (ātmā takes birth only due to association of manna, once dissociated, ātmā attains salvation).

(ऊ २) गर्भ में मन (सत्त्व) से उत्पन्न भाव या गर्भ के सत्त्व भाव (Features developing from manna or sattwa)

यानि खल्वस्य गर्भस्य सत्त्वजानि, यायस्य सत्त्वतः संभवतः संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः; तद्यथा-भक्तिः शीलं शौचं द्वेषः स्मृतिर्माहंस्यागो मात्सर्यं शौर्यं भयं क्रोधस्तन्द्रोत्साहस्तैश्चैष्यं मार्दवं गाम्भीर्यमनवस्थित्वमि-त्येवमादयश्चान्ये, ते सत्त्वविकारा यानुत्तरकालं सत्त्वभेदमधिकृत्योपदेक्ष्यामः ॥ (च० सं० शा० ३/१३)

शुद्ध सत्त्वजानि शौचमास्तिकत्वं कृतज्ञता दाक्षिण्यं व्यवसायः शौर्यं गाम्भीर्यं बुद्धिमैधा स्मृतिः शुक्लधर्मरौचिर्भक्तिरभिषङ्गस्तमोगुणविपर्ययश्च ॥ (अ० सं० शा० ५/१९)

‘सात्त्विकं’ शौचमास्तिकत्वं शुक्लधर्मरौचिर्भक्तिः ॥ (अ० ह० शा० ३/७)

महर्षि चरक ने सत्त्वज भावों का वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भ के सत्त्वज भावों की और उत्पन्न होते हुए गर्भ में सत्व से उत्पन्न होने वाले भावों की व्याख्या की जाती है। जैसे-भक्ति, शील, पवित्रता, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य, शौर्य, भय, क्रोध, तन्द्रा, उत्साह, तीव्र, मृदु या गम्भीर स्वभाव का होना, मन की चञ्चलता आदि अन्य सभी भाव सत्त्वज कहे गए हैं। अग्रिम अध्याय (शा० ४) में सत्वभेद के (मानसिक प्रकृतियों के) आधार पर वर्णित भाव भी सत्त्वज विकार कहे जाते हैं।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि सत्त्वज भावों को आगे वर्णन करेंगे^१, जिसकी व्याख्या में टीकाकार डल्हन ने लिखा है कि गर्भ व्याकारण अध्याय में वर्णित हैं। इस अध्याय में शुद्ध सात्त्विक, राजस एवं तामस प्रकृतियों का वर्णन है।^२

१. सत्त्वजान्युत्पन्नं वक्ष्यामः (उत्तरव गर्भव्याकरणे - डल्हन)। (शु० सं० शा० ३/३३)

२. सु० सं० शा० ४/८१-९८

अष्टाङ्गसंग्रहकार के मतानुसार शुद्ध सत्त्व भाव शौच या पवित्रता, आस्तिकता, कृतज्ञता, कुशलता या दक्षता, व्यवसाय या काम को तत्परता, शौर्य, गंभीरता, बुद्धि (ग्रहणशील), मेधा (प्रज्ञा या धारणशील), स्मृति, स्वच्छता, धर्म में रूचि, भक्ति, काम-क्रोधादि के त्याग की क्षमता एवं तमोगुण विपरीता है।

अष्टाङ्गहृदयकार के मत से पवित्रता, आस्तिकता, धर्म में रूचि एवं मति या बुद्धि सत्त्व भाव है। टीकाकार अरुणदत्त ने वाक्, काय एवं मन तीनों ही की पवित्रता के साथ उपर्युक्त गुणों को उपलक्षण मात्र मानकर कृतज्ञता, दाक्षिण्य, व्यवसाय, शौर्य, गंभीर्य, स्मृति, एवं मेधा आदि को भी सत्त्व माना है।^१

Caraka has enumerated devotion, disposition or habit, piousness, hatred, memory, infatuation, sacrifice or abnegation, jealousy, prowess, fear, anger, drowsiness, zeal, hot subtle or good temper and unsteadiness of *mana* (psyche). He, writes further that the features described under psychic constitution are also features of *sattva*.

Susūta says that features described under psychic constitution should be taken here.

Vāgbhata I has mentioned piousness, belief in existence of god, gratitude, dexterity, quickness for work, prowess, sobriety, *buddhi* (knowledge), *medhā* (brain or intelligence), memory, cleanliness, interest in religion, devotion, capability of giving up sexuality and anger and the qualities opposite to *tanma*.

Vāgbhata II has mentioned piousness, belief in existence of god, cleanliness, interest in religion and *buddhi*, Arunadatta has added piousness of words, deeds and thoughts, gratitude, dexterity, business, sobriety, memory and intelligence to the list.

(ऊ ३) गर्भ के राजस भाव (*Features developing from raja*)

राजसानि दुरुपचाराता अनार्यत्वं शौर्यं मात्सर्यमभितभावहङ्करो लोत्पुत्वं दम्भी मानः क्रोधो हर्षः कामश्च॥

(अ० सं० शा० ५/२०)

‘राजसं’ बहुभाषित्वं मानकुहम्भमात्सरम्॥ (अ० ह० शा० ३/७)

दुरुपचाराता अर्थात् दूसरों से दुर्व्यवहार करना, अनार्यत्व, शौर्य, मात्सर्य अर्थात् ईर्ष्या या द्वेष, बहुत बोलना, अहंकार, लोत्पुत्ता, दम्भ, मान, क्रोध, हर्ष एवं काम आदि राजस भाव हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने बहुभाषित्व, मान, क्रोध, दम्भ एवं मात्सर्य की गणना राजस भावों में की है। टीकाकार अरुणदत्त ने इन सभी गुणों को उपलक्षण मात्र मानकर शौर्य, दुरुपचाराता, लोत्पुत्त्व, हर्ष एवं काम आदि को भी राजस माना है।

Talkativeness, arrogance, anger, ego and jealousy are the features derived from *raja* according to Vāgbhata I and II. Others such as prowess, misbehaviour with others, greed, happiness and sexuality have been added by Vāgbhata I and Arunadatta, besides these Vāgbhata I has included unworthiness or violence and pride also in the list.

(ऊ ४) गर्भ के तामस भाव (*Features derived from tamā*)

तामसायज्ञानं विषादः प्रमादो निद्राऽलस्यं क्षुत्तृणा शोको मात्सर्यं विप्रतिपत्तिः पराभिस्वभ्यान् सत्त्वगुणवैपरीत्यं च॥ (अ० सं० शा० ५/२१)

१. शौच-वैकात्म्यमनसं शुद्धिः.....उपलक्षणं चेतम्। कुतश्चात्ताक्षिण्यव्यवसायशौर्यगम्भीर्यस्मृतिमेधादयोऽपि हि सात्त्विका एव। (अ० ह० शा० ३/७ को अरुण० टी०)

२. उपलक्षणं चेतम्। शौर्यदुरुपचारातालोत्पुत्त्वहर्षकामादयोऽपि राजसा एव। (अ० ह० शा० ३/७ को अरुण० टी०)

‘तामसं’ भयमज्ञानं निद्राऽलस्यं विषादिता ॥ (अ० ह० शा० ३/८)

अज्ञान, विषाद, निद्रा, आलस्य, क्षुधा, तृष्णा, शोक, मात्सर्य, दूसरों के साथ विरोध एवं दूसरों में पूट डालना तथा सत्त्व गुण के विपरीत आचरण तामस भाव हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार के अनुसार भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य एवं विषाद तामस भाव हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने इन सभी को उपलक्षण मात्र मानकर प्रमाद एवं शोक आदि को भी तामस माना है।^१

Ignorance, dejection, sleep, laziness are the features described to be arising from *tama* by Vāgbhata I and II. Vāgbhata I has added carelessness, hunger, thirst, sorrow, jealousy, opposition with others, creation of discord among others and behaviour opposite to *sattva* in the list. Arunadatta has included carelessness and sorrow and Vāgbhata II the fear.

विमर्श (*Comments*)

सत्त्व, रज एवं तम ये तीनों मानस प्रकृतियाँ कही गई हैं, रज एवं तम मन के दोष या विकार हैं। महर्षि चरक, सुश्रुत एवं काश्यप द्वारा गर्भ के चटकों में वर्णित सत्त्व शुद्ध मन का द्योतक है, अतः भावों की गणना करते समय महर्षि चरक ने शुद्ध सत्त्व के साथ ही रज एवं तम रूपी विकारों से उत्पन्न भावों का भी संक्षेप में उल्लेख कर दिया है। आगे शरीरस्थान के ‘महती गर्भविक्रान्ति’ नामक चौथे अध्याय में मन के तीनों सात्त्विक, राजस एवं तामस भेद बताकर इनके संयोग से उत्पन्न सोलह मानस प्रकृतियों का वर्णन है। महर्षि सुश्रुत ने “सत्त्वजन्तुस्रव वक्ष्यामः” (सु० सं० शा० ३/३३) लिखकर शरीरस्थान के चतुर्थ अध्याय में ८१ से ९८ वें श्लोक के अन्तर्गत विभिन्न मानस प्रकृतियों का वर्णन किया है। महर्षि वाग्भट ने सत्त्व (मन) से उत्पन्न होने वाले गर्भ के भावों को शुद्ध मन या सत्त्व तथा दोनों दोषों अर्थात् रज एवं तम के अन्तर्गत विभाजित कर वर्णन किया है, अतः वास्तव में इन आचार्यों के वर्णनों में कोई मतभेद नहीं है। अप्रामाणिक होने के कारण चरक एवं सुश्रुतों के विभिन्न मानस प्रकृतियों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है जब कि संक्षिप्त रूप में वर्णित वाग्भट का मत उद्धृत कर दिया गया है।

मेधा, स्मृति, बुद्धि, काम, क्रोध, आदि अनेक भावों का वर्णन आचार्य आप्तज भावों के अन्तर्गत भी कर चुके हैं, जिसका कारण इन भावों की उत्पत्ति में आत्मा एवं मन दोनों का ही योगदान होना है।

The *sattva*, *raja* and *tama* are the *mānasa prakṛtis* (psychic constitution); other authors have elaborated these under different contexts, since Vāgbhata has mentioned these along with general embryology, hence the same have been given here. *Medhā*, *smṛti*, *buddhi*, anger etc. features have been included even under *ātmajā bhāvas*. It is possible that in the development of these features both the factors i. e. *ātmā* and *sattva* or *raja* participate.

(३) गर्भ के मन के सात्त्विक, राजस आदि होने का कारण (*The cause of dominance of mana with sattva, raja etc*)

सत्त्ववैशेष्यकाराणि पुनस्तेषां तेषां प्रणिनां मातापितृसत्त्वान्यन्तर्वत्याः श्रुत्यश्चाभीक्ष्णं स्वीचिंतं च कर्म सत्त्वविशेषाध्यासश्चेति ॥ (च० सं० शा० ८/१६)

सत्त्ववैशेष्यकाराणि पुनर्मातापितृसत्त्वान्यन्तर्वत्याः श्रुत्यश्चाभीक्ष्णं स्वीचिंतं कर्म भवति पूर्वार्थाध्यासश्चेति ॥ (अ० सं० शा० ९/६६)

१. उपलक्षणं चेतम्। प्रमादशोकादीन्यपि तामसायैव॥ (अ० ह० शा० ३/८ को अरुण० टी०)

गर्भ के मन के सात्विक, राजस आदि होने के कारणों का स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि चरक ने लिखा है कि गर्भ में मन उन प्राणियों के माता-पिता के मन, गर्भिणी के द्राग सुने जाते हुए विषय, अपने पूर्वजन्म के कर्म एवं सत्त्व के अप्वास के अनुरूप होता है।

महर्षि वाग्भट ने चरकोक्त वर्णन का ही अक्षरशः अनुसरण किया है।

The *mana* of fetus attains the characters of *sarwa*, *raja* and *tama* etc. depending upon the psychological status of the mother and father, the topics being listened by the pregnant woman, the influence of deeds of the previous life and specific practice of *mana*.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन व्यक्ति की मानसिक प्रकृति के निर्माण का स्पष्टीकरण करने के तात्पर्य से आचार्यों ने दिया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकृति-निर्माण के चार कारण निर्धारित किये हैं। (१) माता या पिता की मानसिक प्रकृति का प्रभाव (२) गर्भावस्था के समय सुनी हुई कथाओं आदि से हुए माता के मानसिक परिवर्तन का प्रभाव (३) पूर्वजन्म-कर्म (४) अप्वास अर्थात् जन्मोपरान्त व्यक्ति जिस प्रकार के आचरण करने का प्रयत्न करे उसका परिणाम।

The psychological personality of individual develops due to four factors as described above. The specific practice probably refers to the actions done by individual after birth which depend upon the environment and these influence the psychological build up.

मनुष्य से मनुष्य की ही उत्पत्ति का कारण (The cause of progeny being of similar species)

तत्र जरायुजानमापडजानां च प्राणिनामेते गर्भकता भावा यां यां योनिमापद्यन्ते, तस्यां योनौ तथैव तथारूपा भवन्ति; यथा-कनकरजतान्नामसुसौकर्यान्नासिद्धमागन्ति तेषु तेषु मधूच्छिद्यिग्रहेषु, तानि यदा मनुष्यविद्यमापद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते, तस्मात् समुदायप्रभवः सन् गर्भो मनुष्यविग्रहेण जायते; मनुष्यश्च मनुष्यप्रभव उच्यते, तद्वोनिवत् ॥ (च० सं० शा० ३/१६)

कार्याणां च कारणानुविधायित्वात्तत्त्वभावात् प्रतिपद्यते ॥ (अ० सं० शा० २/४)

कारणानुविधायित्वात्कार्याणां तत्त्वभावात्। नानायाः प्रकृतिः सत्त्वो धत्तेऽतो द्रुतलोहवत् ॥

(अ० ह० शा० १/४)

जातौ जातौ खलु स्वभाव एवाकृतिभेदनिर्वायिता भवति।। समस्यके धातुरिव निश्चितः पुरुषः पुरुषमभिनिर्वर्तयति, गौरगमश्चोऽश्वमेवमादि। नृणामपि तु मध्ये गर्भिनिर्वृत्तिः। तत्र द्वयोर्दम्पत्योः स्वभावात् स्वकर्मपरिणामाद्वा प्रजाभिपृच्छिर्भवति ॥ (का० सं० शा० ५/३)

गर्भक भव तो सभी प्राणियों के एक सदृश ही होते हैं, फिर मनुष्य से मनुष्य की ही उत्पत्ति क्यों होती है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि चरक लिखते हैं कि जरायुज और अण्डज प्राणियों के गर्भक भव जिस जिस योनि को प्राप्त करते हैं उस उस योनि में जाकर उसके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्र्यु (गंगा), शीशा आदि को गलाकर मोम के सौंचे में ढाल दिया जाय तो जिस प्रकार का सौंचा रहेगा वैसा आकार ग्रहण करेंगे। उन (स्वर्णादि) को यदि मनुष्य के सौंचे में ढाला जाय तो मनुष्य की आकृति के बन जायेंगे। अतः समुदायप्रभव (मातृदि षड्भावों का गर्भ) जब मनुष्य में प्रवेश करता है तो मनुष्य की उत्पत्ति होती है अतः उस योनि का होने से मनुष्य प्रभव कहा जाता है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। टीकाकार इन्द्र ने स्पष्ट किया है कि कार्य

कारण के ही स्वरूप का अनुगमन करता है, जिस प्रकार तिल से तिल ही उत्पन्न होता है माष नहीं, उसी प्रकार गर्भ के कारण स्वरूप माता, पिता, महापूत, देश, काल, गर्भाशय एवं माता का आहार-विहारादि क्रम रूमी कारणों से उसी स्वरूप का गर्भ उत्पन्न होगा।^१

अष्टाङ्गहृदयकार के मत से भी कारण के अनुसार स्वभाव से ही कार्य होता है जिस प्रकार पिथला हुआ लोहा विभिन्न सौंचों में पड़कर उसकी आकृति को धारण कर लेता है उन्हीं प्रकार स्वभाव से ही सत्त्व विभिन्न योनियों में जाकर उसका स्वरूप धारण करता है।^२

महर्षि काश्यप ने उपर्युक्त दृष्टिकोण का ही समर्थन किया है, उन्होंने लिखा है कि उत्पन्न हुए प्रत्येक जीव में स्वभाव से ही आकृति भेद होता है। जिस प्रकार सौंचे में ढाला हुआ पुरुष पुरुष को, गौ गौ को, अश्व अश्व को उत्पन्न करता है उसी प्रकार मनुष्यों में भी गर्भ की निर्वृत्ति होती है।

Replying to the question that when all six basic factors responsible for conception are similar in all the species, then why from human couple a human child is born? Caraka says that all the six factors of conception when enter in any species taking birth through placenta or egg, attain characters of the same species in the same way as liquified gold, silver, copper, zinc or lead poured in a mould of bee wax acquire the shape of the same mould. If these are poured in man shaped mould then these gold etc. will acquire the shape of a man. Similarly when all these six factors collectively enter the human body, the birth of a human child occurs. Being of the same species, it is said that from man a man is born.

Both the Vāgbhaṭas have mentioned that action or result depends upon its means due to its specific nature. Indu has explained that as from *tila* seeds only *tila* plant will grow not the *māyā* (a type of kidney bean), similarly from collective efforts of mother, father, *bhūtas*, dwelling place, time, uterus and dietetics of the mother, the resultant conception would be of similar shape. Vāgbhaṭa II and Kāśyapa have also given similarity of mould etc. as explained by Caraka.

जरायु की उत्पत्ति (Formation of placenta)

गृहीतार्भाणामार्तववह्निनां स्रोतसां वस्राव्यवकथ्यन्ते गर्भेण, तस्माद् गृहीतार्भाणामार्तवं न दृश्यते। ततस्तदधःप्रतिहतपूर्वमग्नानामपर्वचोपवीयमानमपरेत्यभिधीयते ॥ (सु० सं० शा० ४/२४)

तस्याश्च रजोवाहिनां स्रोतसां वर्त्तमान्युपकथ्यते गर्भेण। तस्मात्ततः परमार्तवं न दृश्यते। ततस्तदधः-प्रतिहतपरमपरं चोपवीयमानमपरेत्यधुः जरायुरित्यन्ये ॥ (अ० सं० शा० २/१०)

गर्भाधान हो जाने पर गर्भ के द्वारा आर्तववह स्रोतस के मुख अवस्रव हो जाते हैं, इसीलिए गर्भाधान के बाद आर्तव (मासिक रजःस्त्रव) नहीं दिखाई देता। तत्पश्चात् अधोभाग से प्रतिहत हुआ आर्तव ऊपर के भाग में जाकर एकत्रित हो

१. कार्य हि कारणस्य स्वरूपमनुगच्छति, तथा च तिलेभ्यस्तिला एव जायते न माषाः, कारणं च यद्रूपस्य मातृपितृमहाभूतदेशकालागर्भाशयमात्राहारदिकम्, तस्य कारणस्य स्वरूपानुगमनादप्यस्य तद्वकृत्यादिमलश्च संभवः तत एव कारणवशादाकृत्यादिवैलक्षण्यम् ॥ अ० सं० शा० २/४ की इन्द्र टी०)

२. द्रुतलोहकालं यथा रूप्यदिवसुज्ज्वलामग्निना द्रुतरूपतां गतमेकरूपमेव सिक्कादिकलितत्वात् नानारूपायां मनुष्याणाकृतौ तद्विधिकं तां तामाकृतिं यथाकलितत्वात् धत्ते, एवं स सत्त्वो नानायां नैव गच्छति, तां तां यथाव्यममाकृतिं धारयति।

(अ० ह० शा० १/४ की अरुण टी०)

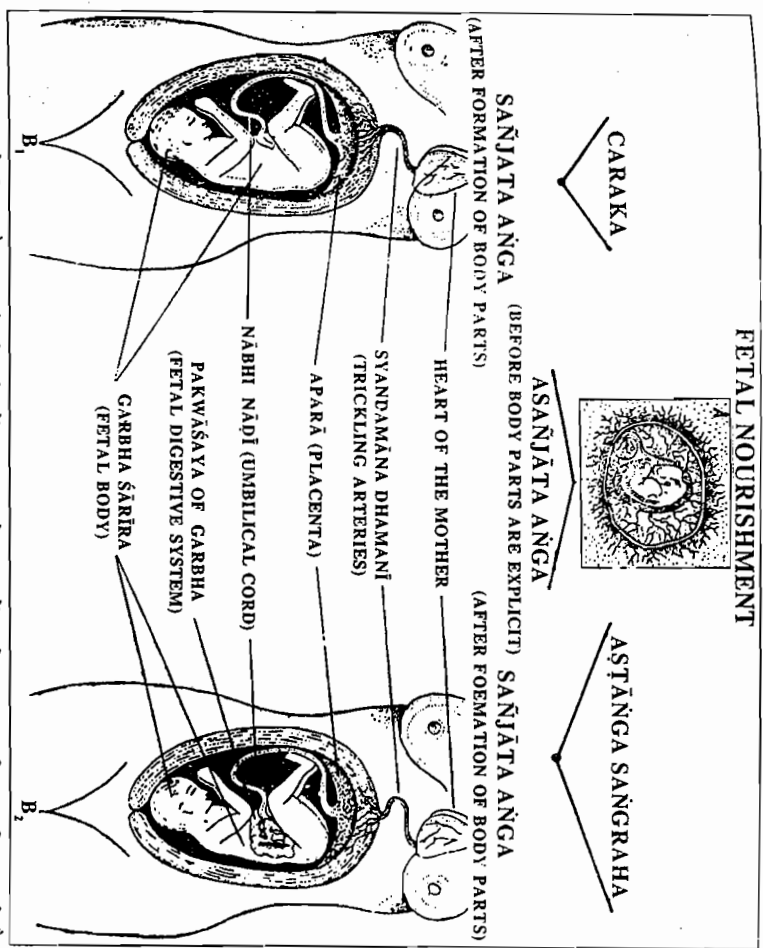
महर्षि चरक ने माता के द्वारा ही गर्भ के पोषण के स्मष्टीकरणार्थ लिखा है कि गर्भिणी म्मो द्वारा सेवित अन्नपान से तीन कार्यों के लिए रस का निर्माण होता है, स्वशरीर-पोषण के लिए, स्तन्य को उत्पत्ति के लिए तथा गर्भ के पोषण के लिए; क्योंकि वह गर्भ उसी आहार से पोषित होकर परतंत्रवृत्ति हो माता पर आश्रित रह अन्तर जीवित रहता है।

महर्षि सुश्रुत के मतानुसार माता के निश्वास, उच्छ्वास, संश्लेष (क्रियाशीलता) एवं म्रन्य से गर्भ भी निश्वास, उच्छ्वास, संश्लेष एवं स्वप्न को प्राप्त होता है अर्थात् जो माता निश्वास लेती है उसी से गर्भ को भी निश्वास मिलता है आदि।

माता की रसवहा नाड़ियों से गर्भ को नाभिनाड़ी प्रतिबद्ध रहती है। यह (नाभिनाड़ी) माता के आहार-रस के वीर्य का अभिवहन करती है। उसके उपरनेह के द्वारा इस गर्भ की वृद्धि होती है। आनिषेक काल से अर्थात् शुक्र के योनि में आनिषेक काल से^१ या गर्भाधान के तत्काल बाद से असंजत अंग-प्रत्यांग-विभागयुक्त (जब तक शरीर के अंग, प्रत्यांग एवं विभाग स्पष्ट नहीं हुए होते) स्थिति तक गर्भ सर्वशरीरवयव को अनुसरण करने वाली तिर्यंगात रसवाही धमनियों के उपरनेह से जीवित रहता है (चित्र ६ अ)। इस गद्य के स्मष्टीकरण में टीकाकार डल्हण ने धमनी के उपरनेह से गर्भ के जीवनधारण को तुलना भरे हुए सरोवर के तट पर स्थित वृक्ष की पोषण-विधि से की है एवं भोजनवयव को उद्ग्रस्त करते हुए लिखा है कि माता के द्वारा प्रयुक्त चतुर्विध (पश्चादि) आहार से उत्पन्न रस के तीन भाग होते हैं स्वशरीर-पोषण, स्तन्योत्पत्ति तथा तीसरे भाग से केदारी-कुल्या न्याय द्वारा गर्भ के पोषण के लिए। टीकाकार डल्हण ने अन्यत्र भी रस से ही गर्भ का पोषण होना माना है।

सुश्रुतक तथा चरकोक वर्णन को ही कुछ भेद के साथ अष्टांगसंग्रहकार ने वर्णन किया है कि गर्भ की स्थिति के बाद वह गर्भ माता के सोने से सोता है एवं जगने से जगता है, उसकी परतंत्रवृत्ति होती है अर्थात् वह माता पर आश्रित रहता है। निषेक के काल से (गर्भाधान के काल से) लेकर (अंग-प्रत्यांग के व्यक्त होने तक) गर्भाशय के उपरनेह एवं उपरवेद से (गर्भ) जीवित रहता है। टीकाकार इड्ड ने आहारोपन्न स्निग्धता से उपरनेह तथा उत्प्रेत से उपरवेद शब्द का स्मष्टीकरण दिया है।^१ तत्पश्चात् अंग प्रत्यांग व्यक्त होने पर इसकी (गर्भ की) नाभि से नाड़ी प्रतिबद्ध रहती है, नाड़ी से अपरा तथा अपरा माता के हृदय से। माता के हृदय से आहार-रस धमनियों के द्वारा स्नान्त होकर अपरा को आता है, अपरा से क्रमशः (नाभिनाड़ी द्वारा) नाभि को, उसके बाद (वह रस) गर्भ के पक्वाशय में पहुँचकर उसकी (गर्भ की) कार्याग्नि से पच्यमान होकर प्रसाद-बहुल (माता से रस रूप में आए हुए होने के कारण) किट्ट का अभाव रहता है। होने के कारण (गर्भ की) धातु आदि का पुष्टिकार होता है (चि० ६ ब०)। साथ ही गर्भ का उपरनेह द्वारा भी पोषण होता है।

१. त्रिधा ह्यापन्नगर्भाग्निश्च रसः प्रतिपद्यते-स्वशरीरपुष्टये, स्तन्याय, गर्भवृद्धये चा स तेनाहारेणापद्यथाः (परतंत्रवृत्तिर्मातृमाश्रित्य) वर्तयत्यन्तरीतः ॥ (च० सं० शा० ६/२३)
२. आनिषेकात् प्रयुति इति आ समन्ततो भोजेन निषेचमग्निषेको योने शुक्रस्य निषेचनं, तन्त्रभूति गर्भाधानं मर्यादीकुल्येधः ॥ (सु० सं० शा० ३/३१ की डल्हण टी०)
३. धमनीनामुपरनेहो जीवयति यथा-पूर्णसःस्मिलोपरनेहोराजातकन्दव्यक्त जीवयति तद्वत् प्रणधारणं करोति^१ यद्यदश्रुति माताऽस्य भोजनं हि चतुर्विधम् तस्मात्प्रदासीभूतं वीर्यं त्रिधा प्रवर्तते भग्नः शरीरं पुण्याति स्तन्यं भगोन वद्धति गर्भः पुण्याति भगोन वद्धति च यथाक्रमं गर्भं कुल्येध केदारो नाडी प्रीणाति तस्मिन्ना इति ॥ (सु० सं० शा० ३/३१ का डल्हण टी०)
४. रसस्य क्रिया निर्दिशन्नाह अन्ये गर्भं तत्पयतीति मन्यन्ते ॥ (सु० सं० सू० १४/३ की डल्हण टी०)
५. उपरनेहः त्रिगद्यत्तम् उपरवेद उत्प्रेतः तौ चाहारायवौ ॥ (अ० सं० शा० २/३२ की इड्ड टी०)



अष्टांगहृदय ने लिखा है कि गर्भ को नाभि में तथा माता के हृदय में नाड़ी (रसवहनाड़ी) सम्बन्धित रहती है, तथा केदारीकुल्या न्याय से गर्भ का पोषण होता है। विषय के स्मष्टीकरणार्थ टीकाकार अरुणदत्त ने अ० सं० वर्णित "व्यकीभवत् रोमकूपैरुपरनेह" आदि सम्पूर्ण वर्णन को ही उद्धृत कर दिया है।^१

महर्षि काश्यप ने गर्भिणी स्त्री के द्वारा सेवित आहार से ही गर्भ के पोषण का वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भिणी स्त्री जो भी अन्नपान सेवन करती है उसके तीन भाग हो जाते हैं, एक माता की पुष्टि के लिए, दूसरा गर्भपोषण के लिए तथा तीसरा स्तन अथवा स्तन्य की पुष्टि के लिए (चरक एवं भेल ने स्तन्य की पुष्टि माना है)। इस प्रकार स्त्री गर्भ का पोषण करती है।^२

महर्षि भेल ने भी केदारीकुल्या न्याय से ही गर्भ-पोषण माना है, तथा चरक सदृश ही अन्नपान से बने रस के तीन

१. (अ० ह० शा० १/५६ की अरुण० टी०)
२. अ) यदन्नपानं प्रापेय गर्भिणी स्त्री निषेचते। रसो निर्वर्तते तादृक् त्रिधा चास्याः प्रवर्तते ॥ मातृपुष्टयधमेकांशो द्वितीयो गर्भपुष्टये तृतीयः स्तनपुष्टयर्थं, नार्था गर्भस्य पुष्टयति ॥ (का० सं० सू० १८/६, ७) आ) गर्भमङ्गै भावयति किञ्चित् स्तन्याय कल्पते ॥ (का० सं० चि० १/१०)
३. नाभ्यां नाडी प्रतिष्ठिता तस्यमपरा मातृहृदयमाश्रिता, तथा मातृशरसोभिर्वह (हर) गर्भं प्रीणयत्यभिर्वयति तद्वथा कुल्याः केदारमभिंसंश्रयतो (न्यो) भावयन्ति तद्वत् ॥ (भे० सं० शा० ४/३३)

भागों का वर्णन किया है यथा गर्भ के पोषण के निम्न, मध्य के लिए तथा रस निर्माण के लिए^१।

आचार्य भवमिश्र ने माता की रसवहा नाड़ों में गर्भ की नाड़ी सम्यक् होने से गर्भ की वृद्धि का वर्णन किया है तथा महर्षि सुश्रुत-सदृश ही माता के निश्चय आदि का होना माना है^२।

Caraka says that with the normalcy of all six factors of conception and use of appropriate diet alongwith mode of life by pregnant woman, the fetus obtaining its nourishment from *rasa* (supplied by mother) by the process of *upasneha* (attracting moisture) and *upaswedā* (osmosis) and influenced by time factor alongwith its own nature or desires grows normally.

The fetus does not feel hunger and thirst and is totally dependent upon the mother. In initial stage when its specific body parts though present are not explicit, it obtains its substance by attracting moisture and osmosis. Afterwards when body parts are conspicuous, a part of nourishment is obtained by *upasneha* (moisture) permeating through pores of skin situated in hair roots of the body and a part through the passage of umbilical cord. The fetal umbilicus is attached to the umbilical cord, umbilical cord to the placenta and placenta to the mother's heart (fig. 6b₁). The mother's heart immerses the placenta (with blood) through running and oozing vessels. Mother's diet contains all the *rasas*, thus the *rasa* derived from this diet gives strength and complexion to the fetus, and the fetus deriving its sustenance from this *rasa* remains alive and develops in the uterus. Caraka further explains the point that what-so-ever diet the pregnant woman consumes, the *rasa* formed from this performs three functions (1) nourishment of the woman's body, (2) formation of milk (3) nourishment to the fetus.

Suśruta explains that inspiration, expiration, activity and sleep of fetus are dependent upon the mother i. e. inspiration of mother gives inspiration to the fetus etc. The fetal umbilical cord is attached to the maternal *rasavahānāṁ* carrying the essence of mother's diet, and the fetus grows (by obtaining nourishment) through *upasneha*. From the time of conception upto the period until the body parts of fetus are not fully conspicuous, it gets its sustenance by *upasneha* through the vessels running obliquely into all body parts (fig. 6a). *Dalhana* has given the simile that as a tree situated on the bank of a full pond derives its nourishment, similarly fetus also receives its nourishment. Further quoting *Bhoja* he says that fetal nourishment takes place by *kedārīkūlyā nyāya*.

Both the *Vāgphatas* have also expressed almost identical views, however, *Vāgphata* I adds that from umbilical cord the *rasa* reaches *pakvāṁyā* (digestive system) of the fetus (fig. 6 b₂), there with its own *kāyāgni* (digestive fire) gets metabolised and provides nourishment to it. Since *rasa* carries pure nutrients, hence, excreta are not formed. *Indu* has explained that unctuousness is *upasneha* and moistening is *upaswedā*.

१. गर्भिण्या(१)सु विद(था) काये रसोऽभिनिर्वर्तते, गर्भस्या(पेत्वा) य सत्यन्त्याय रसत्वाय चेति॥ (धे० सं० शा० ५/७)

२. गर्भस्य नाभिनाड्या तु नाडी रसवहा रिचयाः। संतप्रा तेन गर्भस्य वृद्धिर्वर्तते निरयः॥ ३२१॥

निःश्वसोऽस्त्ववासश्चोभयव्याशांसोऽधिगच्छति। मण्डितैःश्वसितोऽस्त्ववासश्चोभयव्याप्रसंभवान्॥ ३२३॥

संश्लेषः-सञ्जलमप, माता निःश्वसादिकायाश्चेष्टाः करोति तास्यागर्भोऽपि करोतीत्यर्थः॥ (शा० प्र० पूर्व० ३)

Alike Caraka, Kāśyapa has also mentioned about the three divisions of maternal diet but has attributed one part of diet for the nourishment of breasts at one place and to the breast milk at other.

Views of Bhela and Bhāwamiśra are also similar to that mentioned above.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यों ने गर्भ के सम्पूर्ण पोषण को दो विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है, एक व्यक्तवस्था के पूर्व अर्थात् तीसरे मास तक तथा दूसरा व्यक्तवस्था होने पर अर्थात् चौथे मास से प्रसव तक। व्यक्तवस्था के पूर्व गर्भ का पोषण गर्भाशय-स्थित पोषक तत्वों से होता है तथापि मातृदूध-धमनी-अपरा-नाभिनाड़ी मार्ग-द्वारा होता है। आधुनिक विज्ञान दृष्ट्या यदि विचार किया जाय तो यह वर्णन किसी सीमा तक उससे समञ्जस पाता हुआ प्रतीत होता है। बुदबुद (ब्लैस्टिसिस्ट) बनने के पूर्व गर्भ गर्भाशयगुहा स्थित पोषक-तत्वों से पुष्ट होता है। अपरा बनने के पूर्व गर्भ का पोषण गर्भ के चारों ओर स्थित अंकुरों (कोरिऑनिक-विलय) द्वारा स्पन्दन की प्रक्रिया से होता है एवं अपरा-निर्माण के पश्चात् पोषण एक नियमित रक्त परिभ्रमण द्वारा होता है। गर्भ-शरीर-निर्मित रक्त अपरा से शुद्ध एवं पोषक-तत्त्व युक्त होकर नाभि द्वारा होता हुआ गर्भ के शरीर में संचरित होता है एवं पुनः त्याज्य द्रव्य छोड़ने तथा आवश्यक तत्त्व लेने अपरा को नाभिनाड़ी द्वारा ही जाता है (चि० ६)। अपरा में माता एवं गर्भ के रक्त का सीधा सम्बन्ध नहीं होता, आदान-प्रदान स्पन्दन-प्रक्रिया द्वारा ही होता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख महर्षि चरक एवं वाग्भट ने किया है। आयुर्वेदिक संहिताओं में वर्णित अपरा का माता के हृदय से सम्बद्धित होना कुछ युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। ऐसा माना जा सकता है कि गर्भ की पूर्णवस्था में गर्भाशय उदर के ऊपरी भाग तक पहुँच जाता है, अपरा अधिकशतः गर्भाशय के ऊपरी भाग (गर्भाशय-बुन्ड) में ही लगी रहती है एवं यह भाग माता के हृदय के काफी निकट स्थित होता है।

यदि अपरा के हृदय से सम्बन्धित वर्णन का अर्थ हृदय के कार्य से सम्बन्धित करें तो निम्न स्पष्टीकरण दिया जा सकता है—(१) हृदय में रक्त एक ओर से शिराओं से आकर रक्तकोष्ठकों में परिभ्रमित हो दूसरी ओर से धमनियों के द्वारा बाहर जाता है, इसी भाँति अपरा के मातृ-शरीर स्थित भाग की ओर धमनियों से रक्त आता है, अपरा के अङ्गुलों के बीच के स्थान में परिभ्रमण करता है तथा दूसरी ओर स्थित शिराओं से वापस जाता है अर्थात् रक्त-परिभ्रमण में हृदय से सादृश्य होने के कारण अपरा का हृदय से सम्बन्ध बताया गया हो।

(२) हृदय के सदृश ही अपरा का कार्य अर्थात् शुद्ध रक्त को आवश्यक स्थान के लिए भेजना तथा अशुद्ध रक्त का शोधन यथा-स्थान से करवाना आदि हृदय सदृश कार्य है इसीलिए हृदय से सम्बन्ध लिखा गया हो।

महर्षि सुश्रुत एवं उनके अनुयायी भवमिश्र ने नाभिनाड़ी का सम्बन्ध माता की रसवहा नाड़ी से बताया है, यदि रस को त्याज्य मान लिया जाय तो यह वर्णन युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि अपरा में दौड़ती हुई नाभिनाड़ी की रक्तवाहिनियाँ माता के रक्त स्थित त्याज्य से ही पोषण प्राप्त करती हैं।

गर्भ-पोषण के वर्णन में महर्षि चरक, अष्टाङ्गसंहकार आदि ने उपर्युक्त एवं उपर्युक्त दो शब्दों का तथा महर्षि सुश्रुत ने केवल उपर्युक्त शब्द का उल्लेख किया है। टीकाकार इन्द्र द्वारा स्पष्टीकरण सम्भवतः इस दृष्टिकोण से किया गया होगा कि गर्भ कफ-प्रधान होता है, अतः उसे निम्न तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जिसे वह माता के आहार रस से चयनात्मक पुरासरण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्यतया उपर्युक्त से गर्भ के द्वारा विशेषकर उसके लोमकूपाँ द्वारा आवश्यक आर्द्रता का ग्रहण तथा उपर्युक्त से पुरासरण प्रक्रिया द्वारा पोषण का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु वैज्ञानिक दृष्ट्या इन्द्र का स्पष्टीकरण अधिक युक्तिसंगत है अर्थात् गर्भ का सामान्य तथा चयनात्मक दोनों ही प्रकार की पुरासरण क्रियाओं द्वारा पोषण होता है।

It is evident from preceding description that entire fetal nourishment is divided into two stages, before apparent evidence of organs or upto three months and after-wards. Before implantation zygote gets its nourishment from exudates of uterine cavity and after implantation but before complete placenta formation through chorionic villi present all over the embryonic surface, which has very clearly been mentioned by Sūśruta that embryo gets nourishment from the channels running all around it. After three months nourishment is through umbilical vessels (fig. 6). It is difficult to explain the attachment of placenta with mother's heart, this might have been mentioned due to the fact that uterus in its full term reaches upto xiphisternum and mostly placenta is attached to the fundus of uterus, thus reaches to very close proximity of heart. However, probably with this very confusion Sūśruta has mentioned that umbilical cord is attached to *rasavāhā nāḍī* of mother. If *rasa* is accepted as plasma, the clarification can be given that the fine branches of umbilical vessels running in placenta derive the nutrients suspended in plasma of mother's blood.

If the relation of *aparā* with heart is considered as relation to its function, then it can be explained in the following way-(i) as in heart, the blood enters from veins, circulates within its chambers and goes out through arteries, similarly in maternal side of *aparā* (placenta) the blood reaches from maternal arteries, circulates within chorionic villies and goes out from marginal sinuses or veins, in other words the circulation of blood in heart and placenta is almost similar, (ii) to pump pure blood in the body and impure blood to the lungs for purification is main function of heart, similarly placenta receives the impure blood from fetus, purifies it and sends it back to the fetus or due to similarity in function the *aparā* is said to be attached to the heart.

Two words *upasneha* and *upasweda* are given to define the process of fetal nourishment. In explaining these words Indu's version is more logical, because as fetus is dominated by *kapha*, naturally it would need more unctuous substances to replenish this *kapha*, or in other words simple osmosis can not serve the purpose, thus the word *upasneha* probably refers to the selective osmosis, while *upasweda* to simple osmosis. Literally *upasneha* refers to the absorption of moisture through pores of skin situated in hair roots of the body and *upasweda* to osmosis, but earlier explanation is more logical.

गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि (Monthly development of fetus)

(१) प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप (Embryo in first month)

स सर्वगुणवान् गर्भत्वमापन्नः प्रथमे मासि संसृज्यते: सर्वधातुकलुषीकृतः खेटभूतो भवत्यव्यक्तविग्रहः सदसदभूताङ्गावयवः ॥ (च० सं० शा० ४/१)

तत्र प्रथमे मासि कललं जायते ॥ (सु० सं० शा० ३/१८)

तत्र प्रथमे मासे कललं जायते ॥ (अ० सं० शा० २/१३)

अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्मकलली भवेत् ॥ (अ० ह० शा० १/३७)

वह सर्वगुणवान् आत्मा गर्भत्व को प्राप्त होकर (गर्भ में अवलित होकर) प्रथम मास में सभी धातुओं (पञ्चमहाभूतों) के

१. धातुशब्देन च पूजाभ्युपेतो। (च० सं० शा० ४/१ को चक्र० टी०)

से कल्पित होकर या मिश्रित होकर खेटभूत या श्लेष्मा^१ सदृश होकर सत्-असत् अङ्गावयव (सूक्ष्मरूप में अंगवयव की उपस्थिति एवं शूलरूप में अपुष्टिस्थिति) वाले अव्यक्त शरीर का होता है।

महर्षि सुश्रुत एवं अष्टांगसंग्रहकार के मत से प्रथम मास में कलल होता है।

अष्टांगसंग्रहकार के मत से गर्भ प्रथम मास में एक सप्ताह के बाद कलल-स्वरूप अव्यक्तावस्था में रहता है। टीकाकार अरुणदत्त ने एक सप्ताह के पूर्व के गर्भ को श्लेष्म-पिण्डीभूत माना है^२।

महर्षि हारीत ने इस मास में होने वाली गर्भ-वृद्धि का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, इनके मत से रेत या शुक्र (एवं शोणित) के संयोग से पहिले दिन ही कलल (रूप गर्भ) बनता है, दस दिन में शोणित (रेत एवं शोणित मिश्रित गर्भ) बुद्बुदकाकः हो जाता है, वहीं पन्द्रह दिन में घन, बीस दिन में मांसपिण्ड-रूप एवं पच्चीस दिन के प्राप्त होने पर पञ्चभूतात्मक हो जाता है तथा एक महीने में पौषो तत्त्व उत्पन्न हो जाते हैं या स्पष्ट हो जाते हैं^३।

भारविभ्र ने लिखा है कि गर्भाशय में जिस रूप में शुक्र एवं अर्तव मिलते हैं, प्रथम मास में उसी रूप (अर्थात् द्रवरूप) में ही गर्भ रहता है^४।

Caraka says that in the first month *ātma* possessing all the qualities, getting mixed up or vitiated by all the *dhātus* (*bhūtas*) attains the shape resembling the *śleśma* (mucoid character) in which all the body parts though present are not conspicuous.

According to Sūśruta and both Vāgbhāṭas, in the first month embryo is in the shape of *kāla*. Arunadatta says that before one week it is just like a solid mass of phlegm.

Hārta elaborating the subject says that *śūkra* (sperms) after its union (with *śonita*-ovum) attains the form of *kāla* during the first day itself. In ten days the *śonita* (ovum with sperms) becomes *budbuda*, in fifteen days a solid, in twenty days a mass of flesh and in twenty-five days becomes more conspicuous.

Bhāwamīśra opines that *śūkra* and *ārava* deposited in uterus remain in their original character (liquid state) during first month.

विमर्श (Comments)

गर्भाधान के पश्चात् गर्भ 'मांयुल' के रूप में होता है, जो एक सप्ताह के अन्तर 'वैस्तेसिस्ट' का रूप धारण कर लेता है। टीकाकार अरुणदत्त ने सम्भवतः इसी सप्ताह-पूर्व की घन-स्थिति को 'श्लेष्मपिण्डीभूत घन' वर्णन से इंगित किया है। महर्षि हारीत ने सम्भवतः 'मांयुल' को कलल शब्द तथा 'वैस्तेसिस्ट' को बुद्बुद शब्द से संबोधित किया है।

सभी आचार्यों ने शुक्र एवं शोणित के संयोग के साथ ही पञ्चभूतों का गर्भ में आधान माना है, क्योंकि शुक्र-शोणित स्वयं ही पंचतत्त्वात्मक हैं, अतः महर्षि हारीत-द्वारा उपर्युक्त वर्णित गर्भ की पच्चीसवें दिन पंचभूतात्मकता का स्पष्टीकरण

१. खेटः श्लेष्मा, तेन खेटभूत इति श्लेष्मसदृश इत्यर्थः। (च० सं० शा० ४/१ को चक्र० टी०)

२. सप्ताहादवर्गमासगोलकः श्लेष्मपिण्डीभूतो भवेत् ॥ (अ० ह० शा० १/३७ की अष्टा० टी०)

३. प्रथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्कललं च यत्। जायते बुद्बुदकाकं शोणितश्च दशाहनि ॥ १७॥ घन पञ्चदशाहं स्नाद्विंशति मांसपिण्डकम् ॥ पञ्चविंशतमे प्राप्ते पञ्चभूतात्मकसम्भवः ॥ १८॥

मासेन च पिण्डस्य पञ्चतत्त्व प्रजायते ॥ १९॥ (ह० सं० षष्ठस्थान १/१७, से १९)

४. गर्भाशये निपतिर्न यदुत्प्रेरकं तथाऽर्तवम्। तादृगेव द्रवीभूतं प्रथमे मासि तिष्ठति ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/२८९)

कठिन है। ऐसा संभव है कि इस पच्चीस दिन के काल में पाँचों महाभूतों के कार्य (अङ्ग-निर्माण) स्पष्ट हो जाते हों अतः महर्षि हारीत ने इस काल में इन तत्त्वों की उत्पत्ति का वर्णन दिया।

The embryo remains in morula stage for 4-5 days followed by blastocystic stage, probably Arunadatta has referred to this morula as a solid mass before one week and Hārīta has identified morula with *kālā* and blastocyst with *budbuda*. According to āyurvedika philosophy all the five *bhūtas* are present in sperms and ovum and reach there during conception itself, thus description of their association after twenty-five days by Hārīta is a bit confusing, however, it is just possible that since their functions in terms of formation of different body parts become more conspicuous by twenty-five days, hence he has given the description.

(२) द्वितीय मास में गर्भ का स्वरूप (Embryo in second month)

द्वितीये मासि घनः संपद्यते पिण्डः पेश्यवर्तुदं वा। तत्र घनः पुरुषः, पेशी स्त्री, अर्बुदं नपुंसकम् ॥

(च० सं० शा० ४/१०)

द्वितीये शीतोष्णानिलैरभिप्राप्यमानानां महाभूतानां सङ्गतो घनः सञ्जायते, यदि पिण्डः पुमान्, स्त्री चेत् पेशी, नपुंसकं चेद्वर्तुमिति ॥ (सु० सं० शा० ३/१८)

द्वितीये घनः पेश्यवर्तुदं वा तेष्यः क्रमात्पुंजीनपुंसकानि ॥ (अ० सं० शा० २/१३)

द्वितीये मासि कललाब्धः पेश्यवर्तुदं ॥ ४९॥

पुंस्त्रीकलीबाः क्रमात्तेभ्यः ॥ ५०॥ (अ० ह० शा० १)

द्वितीय मास में (गर्भ) पिण्ड, पेशी या अर्बुद के आकार का तथा घन (कठिन) हो जाता है; घन (पिण्डकार) होने पर पुरुष, पेश्याकार होने पर स्त्री एवं अर्बुदकार होने पर नपुंसक उत्पन्न होता है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि द्वितीय मास में शीत (श्लेष्मा), ऊष्मा (पित्त) एवं वायु से पच्यमान महाभूतों का सङ्गत घन (कठिन) हो जाता है। यदि वह पिण्डकार है तो पुरुष, पेश्याकार है तो स्त्री, एवं अर्बुदकार है तो नपुंसक (उत्पन्न होगा)।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने द्वितीय मास में घन, पेशी, अर्बुद की स्थिति क्रमशः पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक की उत्पत्ति के लिए वर्णित की है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी कलल से क्रमशः पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक की उत्पत्ति के लिए घन, पेशी एवं अर्बुद की स्थिति वर्णित की है।

महर्षि हारीत ने पचास दिनों में गर्भ-अङ्कुरों (विभिन्न अङ्गों के द्योतक) की उत्पत्ति मानी है^१।

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत के सदृश तीनों दोषों से पच्यमान गर्भ की घना एवं पुत्रादि के अनुसार आकार का वर्णन किया है^२।

१. पञ्चाशद्दिने संप्रप्ते अङ्कुराण्ड सप्तमः ॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/१९)

२. पुत्रगर्भुतायास्तु गर्भा मासि द्वितीयेक। गर्भो गर्भाशये तस्थः पिण्डकारोऽपरं शृणु ॥ ४५॥

कन्या गर्भवती गर्भे पेशी मासि द्वितीयेको ॥ ४८॥

नपुंसकं यदा गर्भे भवेत् गर्भाऽर्बुदकृतिः ॥ ४९॥

महोत्पत्तिकर्षैस्तत्समैः पच्यमानो द्वितीयेक। कललस्यमहाभूतसमुदायो घनीभवेत् ॥ २१०॥

अत्रमस्तकभयोरेपि पाकहेतुत्वमेव तथोरप्युष्णगोधिकारणत्वात्। यत् उक्तं चरके 'भौमाप्याग्नेयव्याख्याः पञ्चोष्माणः सनामसीः' इति ॥ २१०॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/४५, ४८, ४९, २१०)

In second month the embryo becomes a solid mass. If this solid mass has oval (*pinḍa*) shape the born child would be a male. If elongated (*peṣī*) the female and with rounded (*arbudā*) mass the hermaphrodite. Śūdruta and his follower Bhāwamiśra corroborating the above views have elaborated that these accumulated *mahābhūtas* get processed by the combined action of *śleṣmā*, *pitta* and *vāyu* and become solid. Hārīta is of the view that in fifty days buds (of future body parts) in embryo come up.

(३) तृतीय मास में गर्भ का स्वरूप (Embryo in third month)

तृतीये मासि सर्वोद्भ्याणि सर्वाङ्गावयवाश्च यौगपद्येनाभिर्निवर्तन्ते ॥ (च० सं० शा० ४/११)

तृतीये हस्तपादशिरसं पञ्च पिण्डका निवर्तन्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागाश्च सूक्ष्मे भवति ॥

(सु० सं० शा० ३/१८)

तृतीये पञ्चधा प्ररोहति; तद्वशा-संक्षिप्ती बाहू शिरश्च। सक्थ्यादिप्ररोहैककालमेव च सर्वाङ्गावयवोद्भ्याणि युगात्सम्भवन्ति ॥ (अ० सं० शा० २/१३)

व्यक्ती भवति मासेऽस्य तृतीये गात्रपञ्चकम् ॥

मूर्धा द्वे संक्षिप्तीबाहू सर्वसूक्ष्माङ्गजन्म च। सर्वमेव हि मूर्धाद्यैर्ज्ञानं च सुःखदुःखयोः ॥

(अ० ह० शा० १/५४, ५५)

तृतीये मासि युगपन्निवर्तन्ते यथाक्रमम्। प्रपन्तौ चेतयति वेदनाश्चावबुद्ध्यते ॥

सूक्ष्मप्रत्यक्ककारणस्मृतीये तु मनोऽधिकः ॥ (का० सं० शा० २/४५)

तृतीय मास में सभी इन्द्रियाँ एवं अंगवयव एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। टीकाकार चक्रपाणि ने इस मास में ही सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गों के साथ येमोत्पत्ति का वर्णन किया है^१।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि तीसरे मास में (दो) हाथ, (दो) पैर एवं शिर की पाँच पिण्डकार्यें निकलती हैं, एवं अंग-प्रत्यंग का विभाग सूक्ष्म (स्पष्ट) होता है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी तीसरे मास में संक्षिप्यों, बाहु एवं शिर की पाँच पिण्डकाओं की उत्पत्ति का वर्णन किया है एवं लिखा है कि सक्थि आदि की उत्पत्ति के समय ही सभी अंगवयव एवं इन्द्रियाँ एक साथ ही उत्पन्न होते हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि तृतीय मास में गात्रपंचक अर्थात् शिर, दोनों संक्षिप्यों एवं दोनों बाहुओं की उत्पत्ति होती है। सभी सूक्ष्मगों का जन्म होता है तथा इन शिर आदि की उत्पत्ति के साथ ही सुख-दुःख का भी ज्ञान (गर्भ को) होता है।

महर्षि काश्यप ने भी तृतीय मास में क्रमशः सभी अंगों की एक साथ ही उत्पत्ति मानी है एवं लिखा है कि यह (गर्भ इस मास में) प्रपन्तुन करता है, चेतनायुक्त हो जाता है एवं उसे वेदना का भी ज्ञान होता है। इसी तृतीय मास में अंगों का सूक्ष्म अंग-प्रत्यंग-विभाग विशेषकर मन की अधिक अभिव्यक्ति होती है।

महर्षि हारीत ने तृतीय मास प्राप्त होने पर हस्त-पाद के प्रवर्धन का वर्णन किया है^२।

आचार्य भावमिश्र ने भी तृतीय मास में सभी अंगों की उत्पत्ति मानी है^३।

१. युगपदेव तृतीये मासेऽङ्गप्रत्यङ्गनिष्पत्तेः केशा अपि तदैव जाताः क्रमेण वर्धन्ते न सप्तमे मासि इति भावः।

(च० सं० शा० ८/३२ की चक्र० टी०)

२. मासत्रये तु संप्रप्ते हस्तपादौ प्रवर्धते ॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/२०)

३. तृतीये मासि शिरसो हस्तयोः पादयोस्तथा। पिण्डकाः पञ्च सिष्यन्ति सूक्ष्माङ्गावयवास्ततोः ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/२११)

In third month all the *indrias* and minor body parts become apparent, five buds one for head and four for upper and lower extremities develop. Vāgbhata II opines that with the development of head the embryo is capable of feeling sorrow or happiness. Kāśyapa elaborates that in this month the embryo starts quivering, develops consciousness and can feel pain. Development of body hair is mentioned by Cakrapāṇi.

विमर्श (Comments)

पूर्व पृष्ठों में वर्णित तीन मास तक के गर्भ की वृद्धि का वर्णन आधुनिक श्रूण-विज्ञान के ज्ञान से सामञ्जस्य नहीं रखता, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल ६ सप्ताह के गर्भ में ही हाथ, पैर एवं शिर, यहाँ तक कि अंगुलियाँ भी बनने लग जाती हैं, बाढ़ सप्ताह में तो गर्भ बहुत ही सुस्पष्ट रूप से बढ़ चुका होता है, उसके बहिर्जननांग भी बन जाते हैं। इस वर्णन-भेद का यद्यपि निश्चित स्पष्टीकरण कठिन है, परन्तु ऐसा सम्भव है कि आचार्यों ने अधिकारंशतः स्खित गर्भों के ही आधार पर इस गर्भ-वृद्धि का वर्णन दिया हो। सामान्यतः तीन मास से पूर्व गर्भस्राव होने पर स्वस्थ गर्भ बाहर नहीं निकलता, अधिकारंशतः तो गर्भशयान्तर्गत रक्तस्राव वास्तविक गर्भस्राव के कुछ दिन पूर्व ही प्रारम्भ हो जाता है, एवं स्खित गर्भ एक पिण्डाकार (मोल) रूप का होता है; यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो भी स्कन्दित रक्त तो उपस्थित रहता ही है जिसके कारण ही सम्भवतः इस प्रकार का वर्णन आचार्यों ने दिया हो। तीन मास के बाद गर्भस्राव होने पर अधिकारंशतः वह लघु प्रसव के रूप में होता है। गर्भादक के स्राव के बाद हाथ, पैर एवं शिर से युक्त गर्भ बाहर निकलता है, अतः आचार्यों ने तीसरे मास में सभी अंगों की एक साथ ही उत्पत्ति की कल्पना की।

As all the extremities etc. are already well evident just at 6th week, hence it is difficult to explain the shape of embryo of 2nd month as described in *āyurvedika* classics. It is just possible that the authors have described embryology on the basis of expelled products of conception. Normally upto second month before complete formation of placenta the products of conception are expelled in pieces associated with big blood clots and the authors could not visualize fetal parts. The expelled caruncous mole might have been the source of description of oval, round etc. shapes described earlier. Third month onwards due to formation of bag of membrane and complete placenta, usually abortion resembles miniature labour, wherein fetus with all its intact extremities may be expelled, thus the authors conceived the idea that these might have developed in this very month.

(४) चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप (*Fetus in fourth month*)

चतुर्थे मासि स्थिरत्वमापद्यते गर्भः । (च० सं० शा० ४/२०)

चतुर्थे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्तो भवति, गर्भहृदयव्यक्तिभावत्वेनाधातुभिर्व्यक्तो भवति; कस्मात्? तत्स्थानत्वात् ॥ (सु० सं० शा० ३/१८)

चतुर्थेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्तो गर्भश्च स्थितो भवति । (अ० सं० शा० २/२२)

चतुर्थे व्यक्तताङ्गानां ॥ (अ० ह० शा० १/५७)

चतुर्थे स्थिरतां याति गर्भः कुक्षौ निरामयः ॥ (का० सं० शा० २/५)

चतुर्थ मास में गर्भ में स्थिरता आ जाती है।

महर्षि सुश्रुत के मत से चतुर्थ मास में सभी अङ्ग प्रत्यङ्ग का विभाग स्पष्ट हो जाता है, गर्भ के हृदय के व्यक्त होने से चेतना धातु अभिव्यक्त होती है क्योंकि उसका (चेतना का) स्थान हृदय है। टीकाकार डल्हन ने इसी मास में तेज

के नेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थात् दृगोद्भय के सामान्य निर्माण का वर्णन किया है^१।

अष्टाङ्गसंहकार के अनुसार चतुर्थ मास में अङ्ग प्रत्यङ्ग के विभाग में स्पष्टता एवं गर्भ में स्थिरता आती है। अष्टाङ्गहृदयकार ने चतुर्थ मास में केवल अंगों की व्यक्तता का वर्णन किया है।

महर्षि काश्यप लिखते हैं कि चतुर्थ मास में गर्भ निरुपद्रव रूप से कुक्षि में स्थिर रहता है।

महर्षि हारीत ने साढ़े तीन मास में शिर के सारवत होने एवं चतुर्थ मास में लोमों की उत्पत्ति का वर्णन दिया है^२।

आचार्य भावमिश्र ने भी चतुर्थ मास में अङ्ग-प्रत्यङ्ग की उत्पत्ति एवं हृदय तथा चेतना की व्यक्तता का वर्णन दिया है^३।

Various body parts become more conspicuous and stability to the fetus comes in this month. Manifestation of heart and consciousness associated with heart have been added by Suśruta and Bhāvamiśra. Hārīta opines that in 3 months head becomes stronger and in fourth month lanugo appear.

(५) पञ्चम मास में गर्भ का स्वरूप (*Fetus in fifth month*)

पञ्चमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः ॥ (च० सं० शा० ४/२१)

पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति । (सु० सं० शा० ३/३०)

पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति मांसशोणितोपचयश्च ॥ (अ० सं० शा० २/२३)

..... चेतनायाश्च पञ्चमे ॥ (अ० ह० शा० १/५७)

मांसशोणितवृद्धिस्तु पञ्चमे मासि जीवक ॥ (का० सं० शा० २/६)

पंचम मास में अन्य मांसों की अपेक्षा मांस एवं शोणित का अधिक उपचय होता है।

महर्षि सुश्रुत के मत से पाँचवें मास में मन प्रतिबुद्धतर होता है अर्थात् जागृत होता है।

अष्टाङ्गसंहकार ने पाँचवें मास में मन की प्रतिबुद्धता एवं मांस तथा शोणित के उपचय का वर्णन किया है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने पंचम मास में चेतना की उत्पत्ति मानी है।

महर्षि काश्यप ने पाँचवें मास में मांस एवं शोणित की वृद्धि का वर्णन किया है।

हारीत मतानुसार पाँचवें मास में गर्भ सुजीव हो जाता है^४।

आचार्य भावमिश्र ने पाँचवें मास में मन की प्रतिबुद्धता का ही वर्णन किया है।

In the opinion of Caraka and Kāśyapa during this month accumulation of flesh and blood is relatively more. Suśruta and Bhāvamiśra opine that the *mana* becomes more enlightened. Vāgbhata I has included both the versions mentioned above, Vāgbhata II says that consciousness develops in this month and Hārīta opines that fetus becomes more *sujaiva* (capable to live independently).

१. सु० सं० शा० २/३५ की डल्हन टीका (नेत्र-वर्णोत्पत्ति के अनन्तर उद्भूत)।

२. सार्द्धमासत्रये प्राप्ते शिरश्च सारवद्भवेत् ॥ २० ॥

चतुर्थके च लोमानां सम्भवश्चात्र दृश्यते ॥ २१ ॥ (हा० सं० षष्ठस्थान १/२०, २१)

३. सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागं चतुर्थे स्युः स्फुटानि हि। हृदयव्यक्तभावेन व्यक्त्यते चेतनापि च ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/१९२)

४. पञ्चमे च सुजीवः स्यात् ॥ (हा० सं० षष्ठस्थान १/२१)

५. पञ्चमे मानसं अतिप्रबुद्धते ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३०५)

विमर्श (Comments)

गर्भावस्था के पाँचवें मास या बीस सप्ताह में गर्भ की श्रवणेंद्रिय एवं त्वचा को संज्ञावर नाड़ियों कुछ कार्यक्षम हो जाती है, आयुर्वेदमतानुसार ज्ञान, मन एवं इन्द्रियों के संयोग से ही होता है, अतः इस मास से गर्भ में ज्ञानोत्पत्ति की क्षमता के आधार पर ही संप्रवतः आचार्यों ने मन की उत्पत्ति की कल्पना की है। इक्कीसवें सप्ताह से अट्ठाइसवें सप्ताह का गर्भ यद्यपि सामान्यतया गभशय से बाहर के वातावरण में जीवन-क्षम नहीं होता, परन्तु विशिष्ट व्याख्या से २१वें सप्ताह (४०० ग्राम) अर्थात् पंचम मास के अन्तिम चरण का भी गर्भ जीवित रह सकता है, अतः २१वें से २८वें सप्ताह के गर्भ को जीवनक्षम-पूर्ववस्था का (प्रिविजर्वेल) गर्भ कहा जाता है; महर्षि हारीत द्वारा 'सुजीवता' का वर्णन सम्भवतः इसी तथ्य को इङ्गित करता है।

According to *Āyurvedika* philosophy the knowledge or perception is the result of interaction between *mana* and *indriyas*. Since by 5th month auditory reflexes and peripheral sensory reflexes develop to certain extent, hence the authors have mentioned the enlightenment of *mana*. Normally the fetus of twentyone to twentyeight weeks of gestational age does not survive if delivered, however, under specialized care the fetus of even twentyone week (400 gms.) i. e. last few days of fifth month can survive, thus the fetuses of twentyone to twentyeight weeks are termed as preivable. The description of 'sujiwatā' by Hārīta probably refers to this fact.

(६) षष्ठ मास में गर्भ का स्वरूप (Fetus in sixth month)

षष्ठे मासि गर्भस्य बलवर्णोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः॥ (च० सं० शा० ४/२२)

षष्ठे बुद्धिः॥ (सु० सं० शा० ३/३०)

षष्ठे केशरोमसखास्थिबालादीन्यभिव्यक्तानि बलवर्णोपचयश्च॥ (अ० सं० शा० २/२४)

षष्ठे स्नायुसिरारोमबलवर्णनिखलत्वात्॥ (अ० ह० शा० १/५७)

बलवर्णौजसां बुद्धिः षष्ठे॥ (का० सं० शा० २/७)

छठवें मास में गर्भ के बल एवं वर्ण का उपचय अन्य मासों की अपेक्षा अधिक होता है।

महर्षि सुश्रुत ने छठवें मास में बुद्धि का (की प्रतिबुद्धता का) वर्णन किया है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने छठवें मास में केश, रोम, नख, अस्थि एवं स्नायु आदि की अभिव्यक्ति एवं बल, वर्ण के उपचय का वर्णन दिया है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने छठवें मास में स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नख एवं त्वचा को उत्पत्ति मानी है।

महर्षि काश्यप ने षष्ठ मास में बल, वर्ण एवं ओज की वृद्धि का वर्णन किया है।

महर्षि हारीत ने षष्ठ मास में स्फुरण का वर्णन दिया है^१।

आचार्य भावमिश्र ने भी छठवें मास में बुद्धि की प्रतिबुद्धता को माना है^२।

The opinions of different authors are given here under :

Caraka : Relatively more accumulation of energy and complexion.

Sūruta and Bhāvamiśra : More enlightenment of *buddhi*.

१. षष्ठे प्रस्फुरणं भवेत्॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/२१)

२. षष्ठे बुद्धिश्चातिप्रबुद्धयते॥ (भा० श० पूर्व० ३/३०५)

Vāgbhata I : Development of hair, body hair, nails, bones, tendons and accumulation of energy and complexion.

Vāgbhata II : Tendons, vessels, body hair, nails, skin, energy and complexion.

Kāśyapa : More development of energy, complexion and *ojas*.

Hārīta : Quivering of fetus.

विमर्श (Comments)

छठवें मास या २४-२५ सप्ताह के गर्भ में कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों का विकास काफी सीमा तक हो चुका होता है, त्वचा भी गुलबनी हो जाती है। जिसके कारण ही संप्रवतः आचार्यों ने बुद्धि की उत्पत्ति एवं वर्ण का उपचय लिखा है। यद्यपि शरीर में सूक्ष्म केश (लेन्युगो) ने पाँचवें मास से ही उत्पन्न हो जाते हैं पर सम्भवतः षष्ठ मास में स्पष्टतर अभिव्यक्ति के कारण रोमोत्पत्ति का वर्णन छठवें मास में किया गया। इसी मास में पट्ट अस्थियों (काटिलिज) में चुने (कैल्सियम) का अधिकाधिक एकत्रीकरण हो वे वास्तविक अस्थि का स्वरूप लेती हैं अतः अस्थि की उत्पत्ति का वर्णन आचार्यों ने किया। महर्षि हारीत द्वारा चतुर्थमास में ही रोमोत्पत्ति तथा टीकाकार चक्रपाणि द्वारा तृतीय मास में ही केशोत्पत्ति का वर्णन समुचित प्रतीत नहीं होता^१।

As by 24 to 25th weeks sensory and motor organs attain some maturity and skin becomes pink so the description of *buddhi* and complexion is given. Though lanugo appear in fifth month, however, these are more conspicuous in sixth month, deposition of calcium also starts in this very month, so the classics have described formation of hair and bone. Hārīta and Cakrapāṇi have described the development of body hair in 4th and 3rd month respectively which is not correct.

(७) सप्तम मास में गर्भ का स्वरूप (Fetus in seventh month)

सप्तमे मासि गर्भः सर्वैर्भावैराप्यायते। (च० सं० शा० ४/२३)

सप्तमे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततः॥ (सु० सं० शा० ३/३०)

सप्तमे सर्वाङ्गसम्पूर्णाता। (अ० सं० शा० २/२५)

सर्वैः सर्वाङ्गसंपूर्णो भावैः पुष्यति सप्तमे॥ (अ० ह० शा० १/५८)

सर्वधात्वङ्गसम्पूर्णां वाताग्निकफान्वितः। सप्तमे मासि॥ (का० सं० शा० २/८)

सप्तम मास में गर्भ सभी प्रकार के भावों से पुष्ट होता है। टीकाकार चक्रपाणि ने सर्वभाव शब्द से मांसशोणित अर्थ किया है एवं स्पष्टीकरण में लिखा है कि इस मास में सभी भाव एक साथ ही गर्भ को पूर्ण करते हैं या उसकी वृद्धि करते हैं जबकि अन्य महर्षिों में ऐसा नहीं होता^२।

महर्षि सुश्रुत के मत से सप्तम मास में अंग प्रत्यांग का विभाग प्रव्यक्त होता है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने सप्तम मास में सम्पूर्णता का वर्णन किया है।

अष्टाङ्गहृदयकार के मत से सप्तम मास में सर्वांग सम्पूर्णता एवं सभी भावों की पुष्टि होती है।

१. च० सं० शा० ८/३३ की चक्र० टी० (पृष्ठ १५१) तथा हो० सं० षष्ठस्थान १/२०, २१ (पृष्ठ १५३)

२. सर्वभावैरिति मांसशोणितादिभिः। युगपदेव सर्वैः सप्तमे गर्भ आप्यायते, पूर्वेषु तु मासेषु न सर्वैर्गुणपदिति विशेषः। सर्वाकारैरिति सर्वमांसशोणितादिजन्यरूपैः॥ (च० सं० शा० ४/२३ की चक्र० टी०)

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि सप्तम मास में गर्भ सभी धातुओं एवं अंगों से सम्पूर्ण तथा वात, पित्त एवं कफ से युक्त हो जाता है।

आचार्य भाविमिश्र ने महर्षि सुश्रुत सदृश ही सभी अंगों एवं उपांगों की व्यक्तता का वर्णन किया है।

In seventh month, all the features (muscle, blood, bone) etc, get proper nourishment. All the major and minor body parts are more conspicuous or are fully developed and whole body gets completely associated with *vāta*, *pitta* and *kapha*.

(८) अष्टम मास में ओज का अस्थिरत्व एवं उसका परिणाम (Status of ojas in eighth month and its effect)

अष्टमे मासि गर्भश्च मातृते गर्भतश्च माता रसहारिणीभिः संवाहिनीभिर्मुहुर्मुहोऽजः परस्परत आदातो गर्भस्यासंपूर्णत्वात्। तस्मात्तदा गर्भिणी मुहुर्मुहुर्मुदा युक्ता भवति मुहुर्मुहश्च स्थाना, तथा गर्भः तस्मात्तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमद्धवत्योऽजोऽनवस्थितत्वात्। तं चेवाधर्माभिसमीक्ष्याष्टमं मासमगणयामित्वाचक्षते कुशलाः ॥

(च० सं० शा० ४/२४)

अष्टमेऽस्थिरीभवत्योजः, तत्र जातश्चेज जीवेत्रिरोजस्त्वात्रैर्नैर्हतभागात्वाच्चा ॥ (सु० सं० शा० ३/३०)

अष्टमे गर्भश्च मातृते गर्भतश्च माता रसहारिणीभिर्वाहिनीभिर्मुहुर्मुहोऽजः परस्परमादातो। तस्मात्तदा गर्भिणी मुहुर्मुदिता भवति मुहुर्मुहोर्ना तथा गर्भः। एवं गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमत्तदा भवति ॥ २६॥

ओजसोऽनवस्थितत्वात्। तथा ह्यस्य निष्कर्मणोऽनुष्ठस्य परिवर्तनादीन्गणभवत एवौजसा वियोगः। यद्यपि च किञ्चित्कालमस्योद्धवसनं स्थानच्छिन्नस्येवाङ्गस्यैजःसंस्कारानुवृत्तिवृत्तम्। जनन्यासु स्थिरौजसकतदैकदेशेन रसे संक्रान्ते गतानिरेवेति ॥ २७॥

अन्ये पुरातनः। नैर्हृतभागात्वात्तत्र गर्भस्य मरणम् ॥ २८॥ (अ० सं० शा० २/२६ से २८)

ओजोऽष्टमे सञ्चरति मातापुत्री महुः क्रमात् ॥ ६२॥

तेन तौ स्थानमुदितौ तत्र जाते न जीवति। शिशुरोऽनवस्थानात्रौ संशयिता भवेत् ॥

(अ० ह० शा० १/६२, ६३)

अष्टमे गर्भिणीगर्भावादातो परस्परम्। ओजो रसवहायुकेः पूर्णत्वाच्छल्यत्यस्य ॥

तस्मात्तत्र मुहुर्मुहोर्ना मुहुर्हृष्ट च गर्भिणी। अत्ययं चाप्युते तस्मान्न मासो गण्यतेऽष्टमः ॥

(का० सं० शा० २/१, १०)

अष्टम मास में गर्भ की असम्पूर्णाता के कारण रसहारिणीवाहिनियों (रसवाही धमनियों) के द्वारा ओज बार बार माता से गर्भ एवं गर्भ से माता को आदान प्रदान होता रहता है, अतः गर्भिणी बार बार प्रसन्न एवं बार बार स्थान हो जाती है इसी भाँति गर्भ भी। अतः इस मास में यदि गर्भ का जन्म हो जाय तो ओज की अस्थिरता के कारण जीवन शंकामय होता है। अतः कुशल चिकित्सक अष्टम मास को प्रसव के लिए अगण्य (प्रसव के अगोच्य) समझते हैं।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि अष्टम मास में ओज अस्थिर होता है अतः इस समय उत्पन्न बालक ओज के अनुपस्थित होने एवं नैर्हृत भाग होने के कारण जीवित नहीं रहता। टीकाकार डह्लण का मत है कि यह नैर्हृत भाग राक्षस का अंश होता है जो रक्त के द्वारा बालक में दिया जाता है, ऐसा कुमारतन्त्र में वर्णित है^१।

१. सर्वाण्यङ्गान्युपाङ्गानि भृशं व्यक्तानि सप्तमे ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/३०५)

२. नैर्हृतभागात्वात् राक्षसमंशत्वात् 'नैर्हृत्य भागाश्च बालेषु रक्षेण दत्त' इति कुमारतन्त्रे प्रतिपादितम्।।

(सु० सं० शा० ३/३० से ३/३० की डह्लण टी०)

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने विषय का काफी विस्तार से गणन किया है कि अष्टम मास में ओज रस ले जाने वाली वाहिनियों के द्वारा बार बार माता से गर्भ में एवं गर्भ से माता में अन्तःक्रान्ति है। अतः गर्भिणी बार बार मुदित एवं बार बार स्थान हो जाती है तथा गर्भ का भी जन्म विपत्ति युक्त होता है क्योंकि ओज स्थिर नहीं होता। निष्कर्मणोऽनुष्ठ (प्रसव के लिए उद्यत) गर्भ के परिवर्तनों (प्रसव के समय होने वाले परिवर्तनों) के कारण ओज का वियोग हो जाता है। यद्यपि (जन्म के उपरान्त बालक को) किञ्चित् काल तक श्वसोच्छ्वास होता है परन्तु वह छिन्न अंग की भाँति ओज के संस्कार के ही कारण होता है, अर्थात् जिस प्रकार अंग को शरीर से पृथक् कर देने पर भी कुछ समय तक उसमें जीवन रहने से गति होती रहती है उसी प्रकार ओज के संस्कार मात्र होने में गर्भ भी कुछ काल श्वसोच्छ्वास करता है। माता के शरीर के ओज के स्थिर होने तथा उसके एक भाग का ही स्थलन होने के कारण उसे केवल गतानि ही होती है (मृत्यु नहीं)। कुछ विद्वानों का मत है कि गर्भ की मृत्यु नैर्हृत भाग के कारण होती है।

अष्टाङ्गहृदयकार लिखते हैं कि अष्टम मास में ओज क्रमशः माता एवं पुत्र में संवर्धित होता है, अतः वे स्थान या मुदित होते हैं। इस मास में प्रसवित बालक ओज का अनुपस्थिति के कारण जीवित नहीं रहता एवं माता के जीवन में संशय होता है (अर्थात् वह मर भी सकती है)।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि अष्टम मास में माता एवं गर्भ रसवहा धमनियों के द्वारा परस्पर ओज का आदान प्रदान करते हैं। उस समय गर्भ के अपूर्ण रहने से उसके (ओज के) प्रेश का भी भय रहता है। इसलिए माता कभी स्थान एवं कभी प्रसन्न होती है एवं अन्य अप्रसन्न होते हैं, अतः इस अष्टम मास को प्रसव के लिए अगण्य (अनुपयुक्त) माना है।

महर्षि हारीत ने आठवें मास में गर्भ में अनिन या पाचकानिन का संशय माना है तथा नवें मास में चेष्टेस्थिति का वर्णन दिया है^३।

आचार्य भाविमिश्र जी ने भी ओज की अस्थिरता एवं उसका गर्भ या माता में प्रभाव माना है^४।

Caraka, Vāṇbhāṭa I, II, Kāśyapa and Bhāvamiśra say that due to immaturity of fetus the ojas remains unstable, it moves from mother to fetus and from fetus to the mother through *rasa* carrying channels. Due to this transfer of ojas mother and fetus become happy or dull alternately (happiness when ojas is present and dull when ojas has gone to the other side). If delivery takes place the life becomes doubtful (at the time of delivery if ojas is in the mother, the fetus will die, if it is in the fetus, the life of mother may be in danger). Wise physicians do not consider this month fit for labour.

Suśruta corroborating the instability of ojas has mentioned that child born in this

१. कदाचिजीवति कदाचिन्न जीवतीति संशयितार्थः। (अ० ह० शा० १/६३ की अरण्य टी०)

२. गर्भ अष्टम मास में अपूर्ण रहता है ऐसा महर्षि चक्र आदि ने भी वर्णित किया है एवं युक्तिसंगत भी है अतः यहाँ 'पूर्ण' शब्द उचित प्रतीत नहीं होता, अतः 'ओजोऽसवहतयुकेऽपूर्णत्वाच्छल्यत्यस्य' पाठान्तर अधिक युक्तिसंगत है एवं ऊपर इसी आधार पर ही अर्थ किया गया है।

३. अष्टमेमासि जाते च अग्नियोगः प्रवर्तते। मासे तु नवमे प्राप्ते जायते तस्य चेष्टितम् ॥ २४॥

(ह० सं० षष्ठस्थान १/२२)

४. ओजोऽष्टमे सञ्चरति माता पुत्रौ महुः क्रमात्। तेन तौ स्थानमुदितौ स्थानो जाते न जीवति ॥

न जीवत्यष्टमे जातस्तनौजो न स्थिर यतः। तथा नैर्हृत्यभागात्वात्।

(भा० प्र० पूर्व० ३/३०६, ३०७)

has explained this *maṛṛita* part as part of *vaṇḍaṇa*. Vāgbhata I dilating the subject further says that at the time of expulsion due to various changes occurring in posture of fetus the *ojas* gets dissociated. Though child does respire for a few minutes, it is because of previous association of *ojas*, such as seen in any excised body part which remains alive and moves for a few minutes simply because of its previous association with live body. *Ojas* of mother is stable, only a part of it is expelled with the fetus, thus she becomes only dull but does not die. He further quotes the opinions of others that death of fetus is due to influence of *rākṣasa*.

and in ninth month activities are more in *Shivrat* (Measures to prevent labour in eighth month)

ततो बलिं मांसौदनमस्मै दापयत् । (सु० सं० १॥ ३/२०)
मांसौदनबलिं चात्र निवीत् ॥

महर्षि सुश्रुत ने इस मास में (नैऋत के लिए) मास छह आठवें तिथि के पवित्र धर्मों के पवित्र धर्मों को देखा, पवित्र, ब्रह्मचारिणी

अष्टाङ्गसंग्रहकार लिखते हैं कि इस (अष्टम मास के) प्रलय में आर्यावर्त का प्रायः अन्धकार छा जाता है। अथवा अष्टम मास की रात्रि को जल पी दी जानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु नैश्चल भाग एवं देवता आदि की आराधना में तत्पर रहे। मांस एवं अंडन को बलि भी दी जानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु नैश्चल भाग या भूदादि के कारण होती है न कि ओज की अस्थिरता में।

The pregnant woman should take daily bath, live a pious life, observe celibacy and should remain busy in worship of god. The oblation of meat and cooked rice should be offered to propitiate the *rākṣasas*, because the death of the child is due to *rākṣasas*, which are said to be inflicted upon the child by *mātrā*.

गर्भ का सर्वाप्रथम उत्पन्न होने वाला अङ्ग (First born body part of the fetus)

तमेवमुक्तवन्तमग्निप्रवेशं भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच—पूर्वमुक्तेतदुत्तरार्धावकात्तौ यथाऽयमग्निनिर्वर्तते कुक्षौ, यज्यास्य यदा संतिष्ठतेऽङ्गनात्तम् । विप्रतिवादात्मन्त्रं बह्विधाः सूत्रकृतामुषीणां सन्ति सर्वेषां; तानपि निबोधेय्यमानान—शिः पूर्वमग्निनिर्वर्तते कुक्षाविति कुमारशिः भद्राजः पर्ययति, सर्वेन्द्रियाणां तदधिष्ठानमिति कृत्वा; इदमिति काङ्क्षान्वने वाल्हीकाभिषक्, चेतनाधिष्ठानत्वात्; नाभिरेति भद्रकाव्यः आहारगाम इति कृत्वा; निबोधेय्यमुदमिति भद्रशौनकः, मारुताधिष्ठानत्वात्, हस्तादमिति बडिशः, तत्कारणत्वात्, पुरुषस्य; इन्द्रियाणीति जन्तुको

१. तत्राष्टमे मासे नैर्ऋतभागात्वात् पूतावसात्वात्तस्य कालस्य गणमस्य मशमाहुः । न (आवासात्) तस्य तस्य ।
(अ० सं० शा० २२९ को इट्ट टी०)

२.दापयेत्तद्वलिं ततः ।

..... दापयेद्वलि ततः ।
नैर्ऋत्याय भागश्च बालेषु स्वेष्टेण दत्तः, यत उक्तं कुमातरने 'अष्टमे मासि नैर्ऋत्याय मांसोदयं बलिं दापयेदिति' ॥
(भा० प्र० पूर्व० ३/३०७)

१५१

वैवेकः, तात्पर्य बुद्ध्याधिष्ठानातीति कृत्वा; परोक्षत्वादिचित्तमिति मारीयः कश्यपः; सर्वाङ्गभित्तित्तुत्तुपादिति ध्वन्तरीः, तदुपपन्नं, सर्वाङ्गानां तुल्यकालाभिनिर्वृत्तित्वाद्बद्धपञ्चमीनाम् । सर्वाङ्गानां ह्यस्य हृदयं मूलमाधिष्ठानं च केवाङ्गिद्धावानाम्, न च तस्मात् पूर्वाभिनिर्वृतिषोः, तस्माद्बद्धपञ्चमीनां सर्वाङ्गानां तुल्यकालाभिनिर्वृतिः सर्वे भावा ह्यन्येत्यप्रतिबद्धाः; तस्मादृष्टाभूतत्वं साधु ॥ (चं सं० श्रां० ६/२९)

गर्भस्य हि सम्भवतः पूर्वं शिरः सम्भवतीत्याह शौनकः; शिरोमूलत्वात् प्रधानानिन्द्रियाणां (देहिन्द्रियाणांपाप-
पाठेन); हृदयमिति कृतीवर्यो बुद्धेर्द्रोमसश्च स्थानत्वात्; नाभिमिति पाराशर्यः, ततो हि वक्ष्यते देशे देहिनाः,
पाणिपादमिति मार्कण्डेयः, तन्मूलत्वात् चोष्टया गर्भस्य; मध्यशरीरमिति सुभूतिर्गौतमः, तत्रिबद्धत्वात्
सर्वांगसम्भवस्य । तत् तु न सम्यक् । सर्वाङ्गप्रत्यङ्गानि युगपत् सम्भवतीत्याह धन्वन्तरिः, गर्भस्य सूक्ष्मत्वात्पोपलभ्यते
वंशाङ्गुलवच्चतुःफलवच्च । तद्यथा - चतुःफले परिधेके केशरामांसादिश्चिमज्जनः पृथक् पृथक्प्रादुश्यते कालप्रकर्षात् ,
तात्वेन तरुणे तोपलभ्यते सूक्ष्मत्वात्, तेषां सूक्ष्माणां केशरादीनां कालः प्रव्यक्तानं करोति, एतेनैव वंशाङ्गुरोऽपि
व्याख्यातः । एवं गर्भस्य तरुण्ये सर्वेष्वङ्गप्रत्यङ्गेषु सत्त्वापि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः, तात्वेन कालप्रकर्षात् प्रव्यक्तानि
भवन्ति ॥ (सु० सं० शां० ३/३२)

इस प्रकार प्रश्न करते हुए अनिवेश से भावान आश्रय ने कहा, कि पूर्व वर्णित गर्भावकांति अध्याय में कुक्षि में गर्भ का अभिनिर्वर्तन, संतिष्ठन एवं उसके अंगों की उत्पत्ति का वर्णन किया जा चुका है। परन्तु प्रथम उत्पन्न अंग के बारे में सूत्रकार ऋषियों में मतभेद है। उसे मैं भी कहता हूँ, सुनो कुमारशिरा भगवान् के मत से गर्भ में सर्वप्रथम शिर की उत्पत्ति होती है क्योंकि शिर ही सभी इन्द्रियों का आश्रय है। वाल्मीकि देश के वैद्य कांकायन का मत है कि चेतनाधिष्ठान होने के कारण सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है, भद्रकाय के मत से आहारागमन के कारण सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति होती है। भद्रायौनक के मत से मातराधिष्ठान होने के कारण सर्वप्रथम पक्वाशय और गुदा उत्पन्न होते हैं। बह्विश के मतानुसार पुरुष के प्रधान करण होने के कारण सर्वप्रथम हस्त एवं पाद की उत्पत्ति होती है। वैदेह जनक का मत है कि बृद्धि का अधिष्ठान होने के कारण सर्वप्रथम इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। मारीच काश्यप का मत है कि चौँके गर्भाङ्ग की उत्पत्ति परोक्ष में (उदरगुहान्तर्गत) होती है अतः यह विषय विचारणीय नहीं है। भगवान् धन्वन्तरि का मत है कि सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गों की उत्पत्ति एक साथ होती है। यही मत युक्तिसंगत है क्योंकि हृदय आदि सभी अंगों की उत्पत्ति एक साथ होती है। सर्वाङ्गों एवं किञ्चित् भावों (ओज, मन, आत्मा, बुद्धि आदि) का मूलाधिष्ठान होने से हृदय की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है ऐसा पूर्ववर्णित मत युक्तिसंगत नहीं है। हृदय प्रभृति सभी अंगों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है क्योंकि सभी भाव एक के साथ एक सम्बन्धित हैं, अतः सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं यह मत युक्तिसंगत है। अन्यत्र भी महर्षि चक्र ने सभी इन्द्रियों एवं अङ्ग-प्रत्यङ्गों की एक साथ उत्पत्ति का वर्णन दिया है।

महर्षि सुश्रुत न विभिन्न वैज्ञानिकों के मत का इस प्रकार उल्लेख किया है कि शौक क्रिषि के मत से इन्द्रियों का मूल आधार शिर होने से सर्वप्रथम शिर की उत्पत्ति होती है। कृत्वाथ के मत से बृद्धि एवं मन का स्थान होने से हृदय की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। पाराशर के मत से नाभि द्वारा ही शरीर की बृद्धि होने से सर्वप्रथम नाभि उत्पन्न होती है। नाकपण्ड्रेय के मत से चेष्टाओं का मूल होने के कारण पाणि-पाद की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। सम्पूर्ण गात्रों की उत्पत्ति मध्य शरीर में निबद्ध होने से सर्वप्रथम मध्य शरीर ही उत्पन्न होता है ऐसा सुभुषि (महर्षि) गौतम का मत है। भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं है, गर्भ के सभी अंग-प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं, वंशानुकर या आन्ध्रफल के सदृश सूक्ष्म होने से दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे आन्ध्रफल में कालाप्रकर्ष से परिपक्व होने पर केशर, मांस (पट्टा), अस्थि (गुल्टी) एवं मज्जा (गुल्टी की गिरी) पृथक् पृथक् स्पष्ट दिखाई देते हैं, वे ही तरुण (कच्चे) फल में सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते, उन सूक्ष्म केशर आदि को समग्र ही प्रव्यक्त करता है, इसी प्रकार वंशानुकर का भी वर्णन समझना चाहिए। इसी प्रकार गर्भ की तरुणावस्था में सभी अंग प्रत्यंगों के सूक्ष्म होने से उनकी उपलब्धि (दृष्टिगोचरता) नहीं होती, समय पारक वे ही व्यक्त हो जाते हैं।

१. एवमस्योद्दिष्टाण्यङ्गावयवांश्च यौगपद्येनाभिनिर्वर्तते॥ (च० सं० शा० ४/१४)

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत-सदृश ही वर्णन दिया है, एवं सर्वांगों की एक साथ उत्पत्ति के लिए महर्षि सुश्रुत-सदृश ही आम्रफल का उद्धरण भी दिया है।

महर्षि भेल ने अधिकारशतः महर्षि चरक का ही अनुामन किया है इन्होंने कारणय को उद्घृत करते हुए सर्वप्रथम चक्षु की भी उत्पत्ति मानी है^१।

गर्भ के सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले अंग को सम्भाषा को उद्घृत करते हुए विभिन्न आचार्यों ने उस मत के मानने वाले ऋषियों का उल्लेख किया है जिस नामोल्लेख में चरक, सुश्रुत, भेलदि में कुछ वैभिन्न्य है जो निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

तालिका-६

संहिता-वर्णित ऋषि-नाम

गर्भ का प्रथम उत्पन्न अङ्ग	चरक	सुश्रुत एवं भावमिश्र	भेल
अवित्राणीय-विषय	मारीच कश्यप	-	-
शिर	कुमाशिराभद्राज	शौनक	भद्राज
हृदय	कांकापन	कृतवीर्य	पारशर
नाभि	भद्रकाप्य	पारशर	खण्डकाप्य
पञ्चाशय एवं गुदा	भद्रशौनक	-	शौनक
पाणिपाद	बडिशा	मार्कण्डेय	बडिशा
इन्द्रियाँ	वैदेह जनक	-	-
मध्यशरीर	-	गौतम	-
चक्षु	-	धन्वन्तरि एवं आत्रेय	कारणय
सर्वाङ्ग-प्रत्यङ्ग	पुनर्वसु	धन्वन्तरि	आत्रेय पुनर्वसु

१. शिरो भवति चाङ्गस्य पूर्वमित्याह शौनकः। शिरस्येवोपजायते प्रधानानीन्द्रियाणि यत् ॥ ३०९॥

हृदयं जायते पूर्वं कृतवीर्योऽवदन्मुनिः। बुद्धेश्च मनसापि यतस्तत्स्थानमीरितम् ॥ ३१०॥

पाशायं इति ग्राह पूर्वं नाभिसमुद्भवः। प्राणो यत्र स्थितो देहं बद्धंयत्पुंससंयुतः ॥ ३११॥

पाणिपादं भवत्पूर्वं मार्कण्डेयमुनेर्मतम्। देहिनाः सकलाश्चैष्टः पाणिपादाश्रया यतः ॥ ३१२॥

प्रथमं जायते कोष्ठं ततः सर्वांगसम्भवः। एतत् कथयामास गौतमो मुनिपुङ्गवः ॥ ३१३॥

सर्वायङ्गान्युपाङ्गानि युगापत्सम्भवन्ति हि। सुक्ष्मत्वाजोपलभ्यन्ते मां धन्वन्तरेरिदम् ॥ ३१४॥

आम्रस्यापुनरुत्पत्तेरिति युगापत्सामिथ्यमजादयो। तस्मिन्ने न पृथक्पृथक्नुतया पुष्टस्त एव स्फुटाः ॥

एवं गर्भसमुद्भवे त्ववयवाः सर्वे भवन्त्येकदा। तस्याः सूक्ष्मताया न ते प्रकटतामायाति वृद्धिं गताः ॥ ३१५॥

(भा० प्र० पूर्व० ३/३०९ से ३१५)

२. अत्राह किञ्चल(जाल)स्य गर्भस्य प्रथमं संभवति ? इत्थं पादाविति बवि(डि)शः, तद्यतिष्ठित(त्वा)त्सरीरस्य। पश्चादुत्पन्न इति शौनकः, तदाश्रित्वाद्वायोः। नाभिर्नरिति खण्डकाप्यः, तत्र नाडी प्रतिष्ठ(धित)त्वात्। हृदयमिति पारशरः, विज्ञानमूलकानां तन्मूलत्वात्। शिर इति भारद्वाजः, शरीरस्य तन्मूलत्वात्। चक्षुरिति कश्यपः। नेत्याह भगवान् पुनर्वसुआत्रेयः। तस्मादुद्भवेवाप्य प्रथमं सम्भवति। तत्र सर्वे शरीरादेशसम्भवाच्चलत्तुर्दक्षेहोत्पन्नाः ॥ (भे० सं० शा० ४/३११)

इस वैभिन्न्य का कारण संभवतः सम्भाषा में एक से अधिक ऋषियों द्वारा एक मत का संपादन या एक नामधारी विभिन्न ऋषियों का मत वैभिन्न्य हो सकता है, अथवा यह उस काल की लेखनशैली का श्रोतक हो, जिसमें महर्षि आत्रेय आदि ने सभी सम्भाष्य आशंकाओं को रखकर अन्त में अपना समन्वयात्मक मत व्यक्त किया। शृणु-विज्ञान-दृष्ट्या महर्षि आत्रेय पुनर्वसु एवं धन्वन्तरि का मत कि सभी अंग-प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं अधिक युक्तिसंगत है।

There existed a lot controversy about the body part developing first and a good debate ensued. Summing up the opinion god Dhanwantari and Ātreya Punarvasu explained that all the body parts develop simultaneously, the logic that being basic supporting structure or abode of various features (*oja, mana, ātmā, buddhi* etc.) the heart comes first is not correct. All the features are interrelated to each other and develop simultaneously (quoted by Caraka). He explains further (quoted by Suśruta) giving the example of sprout of bamboo or fruit of mango, that as in the ripe mango fruit all its parts i. e. fibres, pulp, nut and kernel are very conspicuous but are not so when it is unripe and small. It is only time factor which is responsible for this change. Similar happenings are seen in sprout of bamboo (when it grows, bamboo-wood, leaves etc. are apparent but not in earlier stage). Similarly in young embryo all the features inspite of their presence are not conspicuous but are apparent after its maturity.

Caraka, Suśruta etc. have quoted opinions of others. Different debaters with the body parts mentioned by them as to be first born are given hereunder.

First born body part	Classics mentioning the debaters		
	Caraka	Suśruta and Bhāvaśiṣṭa	Bhela
1 Not to be discussed	Māṛica Kaśyapa	—	—
2. Head	Kumārāśirā Bhara-dwāja	Śaunaka	Bharadvāja
3. Heart	Kāṅkāyana	Kṛtāvīrya	Pārāśara
4 Umbilicus	Bhadrakāpya	Pārāśara	Khaṇḍakāpya
5 Duodinum and anus	Bhadrāśaunaka	—	Śaunaka
6. Extremities	Baḍiśa	Mārkaṇḍeya	Baḍiśa
7: <i>Indriyas</i>	Vaideha Janaka	—	—
8. Trunk	—	Gautama	—
9. Eyes	—	—	Kāśyapa
10. All body parts together	Dhanwantari and Ātreya Punaṛvasu	Dhanwantari	Ātreya Punaṛvasu

गर्भ के अङ्ग-प्रत्यङ्ग की उत्पत्ति के घटक (*Constituents of different body parts of the fetus*)

गर्भस्य यकृत्प्लीहानौ शोणितजौ। शोणितकेन्द्रप्रभवः फुफुसः। शोणितकिट्टप्रभवः उज्जुकः॥

असृजः श्लेष्मणश्चापि यः प्रसादः परो मतः । तं पच्यमानं पितेन वायुश्चायनुधावति ॥ ततोऽस्यान्वाणि जायते गुदं वलितश्च देहिनः । उदरे पच्यमानानामाध्यानाद् रुक्मसारवत् ॥ कफशोणितमांसानां साराजिह्वा प्रजायते । यथाशंभूष्मणा युक्तो वायुः स्त्रोतांसि दारयेत् ॥ अनुप्रविश्य पितृशितं पेशीर्विभजने तथा । मेदसः स्नेहमादाय शिरा स्नायुत्समायुयात् ॥ सिराणां तु पटुः पाकः स्नायूनां च ततः खरः । आशयाध्यासयोगेन करोत्याशयसम्भवम् ॥

रक्तमेदःप्रसादाद् वृक्षैः । मांसासृक्कफमेदःप्रसादाद् वृषणं । शोणितकफप्रसादनं हृदयं, यदाश्रया हि धमन्यः प्राणवहः । तस्याधो वामतः स्त्रीहा पुष्पुसश्च, दक्षिणतो यकृतं कर्लोम च ॥ (सु० सं० शा० ४/२६ से ३९)

तत्र समानेनाध्यायमानस्य देहोष्मणा पच्यमानस्य शोणितस्याच्छतो जायते यकृतस्त्रीहा च । रक्तफेनाफुष्पुसम् । रक्तकिण्डुदुन्दुकः । रक्तमेदः प्रसादाद्वृक्षैः । रक्तमांसप्रसादादन्वाणि । ... रक्तस्यानितयोगात्कालीयम् ॥ ४८॥

हृदयं पुनः श्लेष्मरक्तप्रसादात्सम्भवति । ... तस्य वामपथे स्त्रीहा पुष्पुसश्च दक्षिणतो यकृतं कर्लोम च ॥ ४९॥

तथा कफरक्तवाहिनां स्रोतसां महाभूतानां च प्रसादादिद्वित्र्याणि ॥ ५०॥

मांसासृक्कफप्रसादात् जिह्वा जायते ॥ ५७॥

मांसासृक्कफमेदः प्रसादाद्वृषणविवि ॥ ५८॥ (अ० सं० शा० ५/४८-५०, ५७, ५८)

प्राणान्स्त्रु बीजधातुं हि विभजत्यस्थिसंख्यं स्थ या । प्रविष्टुमात्रं बीजं हि रक्तेन परिवेष्टयेत् ॥

शुक्रादस्थ्यस्थितो मांसमुभाभ्यां स्नायवः स्मृतः । सर्वोद्विग्राणि गर्भस्य सर्वाङ्गवयवसंस्था ॥

(का० सं० शा० २/२३)

शोणितान्द्रुदयं तस्य जायते हृदयाद्यकृतं । यकृतो जायते स्त्रीहा स्त्रीहः पुष्पुसमुच्यते ॥

परस्परनिबन्धानि सर्वाण्येतानि भार्गव । ॥ (का० सं० शा० ३/५, ६)

महर्षि सुश्रुत ने गर्भ-शरीर के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति का वर्णन करते समय लिखा है कि गर्भ के रक्त से यकृत एवं स्त्रीहा, रक्त के फेन से पुष्पुस और रक्त के मल से उण्डुक की उत्पत्ति होती है । श्लेष्मा एवं रक्त के प्रसाद या सारमा भाग के पित के द्वारा पचने समय उसमें वायु भी आ जाती है । इस (मिश्रण) से आन्त्र, गुदा एवं बरिस की उत्पत्ति होती है । आध्यापन से उत्पन्न, सोने के सारभाग-सदृश उदर में (वायु एवं पित द्वारा) पकाए जाते हुए कफ, शोणित एवं मांस के सार भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है । पित से युक्त वायु आवश्यकतानुसार स्रोतसों को निर्दिष्ट (या निर्माण) एवं मांस में प्रवेश करके उसे पेशियों में विभक्त करती है; मेद से स्नेह भाग लेकर उसे शिरा एवं स्नायु का रूप देती है, जिनमें शिराओं का पटु तथा स्नायु का खर पाक होता है । वही (पित युक्त वायु मांस में प्रवेश करके) अवस्थित होकर बार बार अभ्यास करके आशयों की उत्पत्ति करती है । रक्त एवं मेद के प्रसाद (सार भाग) से वृक्क, मांस, रक्त, कफ एवं मेद के प्रसाद भाग से वृषण एवं शोणित तथा कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है, जिसके आश्रय में प्राणवह धमनियाँ रहती हैं; उस हृदय के गोच वाम पार्श्व में स्त्रीहा एवं पुष्पुस तथा दक्षिण पार्श्व में यकृत एवं कर्लोम होता है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि समान वायु के वेग के कारण शरीर की अर्धभाग द्वारा रक्त का पाचन होने से उत्पन्न अञ्च (प्रसाद) भाग से यकृत और स्त्रीहा का निर्माण होता है । रक्त के फेन से पुष्पुस, रक्त के किण्डु से उण्डुक, रक्त एवं मेद के प्रसाद से वृक्क एवं रक्त तथा मांस के प्रसाद से आन्त्र का निर्माण होता है । श्लेष्म एवं रक्त के प्रसाद से हृदय उत्पन्न होता है । जिसके वाम पार्श्व में स्त्रीहा एवं पुष्पुस तथा दक्षिण पार्श्व में यकृत एवं कर्लोम होते हैं । कफ एवं रक्तवह स्रोतसों एवं महाभूतों के प्रसाद से इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । मांस, रक्त एवं कफ के प्रसाद से जिह्वा उत्पन्न होती है । मांस, रक्त, कफ एवं मेद के प्रसाद से वृषण की उत्पत्ति होती है ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि प्राण (जीवात्मन) बीज धातु को अस्थि-संख्या या अस्थि-संस्थान के अनुसार विभक्त करता है । शरीर में प्रविष्ट हुआ बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है । शुक्र से गर्भ की अस्थियाँ, अस्थि से मांस एवं उत दोनों से (अस्थि एवं मांस से) स्नायु का एवं गर्भ के सभी अंगवयव तथा इन्द्रियों का निर्माण होता है । शोणित से हृदय, हृदय से यकृत, यकृत से स्त्रीहा एवं स्त्रीहा से पुष्पुस की उत्पत्ति होती है, एवं ये अंग आपस में एक दूसरे से निबन्धित रहते हैं ।

महर्षि हारीत ने विभिन्न अंगों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि वात एवं रक्त से त्वचा उत्पन्न होती है । मांस त्वचा के आश्रय में रहता है । शुक्र एवं श्लेष्मा से मेद एवं रक्त से रस तथा अस्थि की उत्पत्ति होती है । हृदय में पित आश्रित या स्थित है, यकृत वात-रक्त-मय है । रक्त, श्लेष्मा तथा रस का आश्रय उरु या जंघा है, स्त्रीहा-कफ, रक्त एवं श्लेष्म-मय तथा पेशियाँ कफ एवं रक्तमय हैं ।

Susruta says that fetal liver and spleen get their origin from *rakta*, lung from the foam and caecum from the waste product of *rakta*. The cream (*āra*) of *ślesmā* and *rakta* getting metabolised by *pitta* and followed by *vāyu* form intestines, anus and bladder. Just as pure gold is obtained by blowing (air into fire and heating the gold), similarly the tongue is formed from the best part of *kapha*, *rakta* and *māṃsa* getting metabolised in the abdomen. The *vāyu* associated with *lūsmā* (*pitta*) canalizes the *śrotasas* (channels), entering the *māṃsa* (flesh) divides it into *peṣṭis* (muscles), incorporating unctuous portion of *medas* forms *śīrā* (vessels) and *śrāyū* (tendons) by *mṛdū* (milk) and *khara* (strong) *pāka* (heating) respectively; this very *vāyu* by continuous practice or repeated actions forms the *āśayās* (visceras). The kidneys are derived from the cream portion of *rakta* and *medas*, the testicles (total scrotum) from cream of *māṃsa*, *rakta*, *kapha* and *medas* and heart from the cream of *rakta* and *kapha*. This heart supports all the *prāṇavāhā dhāmanīs* (life carrying channels). Below the heart on the left side is spleen and lungs and on the right liver and *kloma* (pancreas).

Vāgbhaṭa I says that the liver and spleen are derived from essence part of blood formed due to action of body heat influenced by force of *śantāma vāyu*. From froth of blood the lungs; from waste product of blood and *medas* the *vrkta* (kidneys) and from essence part of blood and flesh the intestines are formed. From essence part of *ślesmā* and blood, the heart is formed, in left side of which the spleen and lungs and on right side the liver and *kloma* are situated. From essence part of *kaphavāha* and *raktavāha śrotasas* as well as *mahābhūtas* the *indriyas* are derived. The tongue develops from essence part of flesh, blood and *kapha* and the testicles from essence part of flesh, blood, *kapha* and *medas*.

Kāśyapa opines that *prāṇa* (*jīva*) divides the *bijadhānu* (zygote) according to number or systems of *asthīs* (bones). The *bija* after its entry into the body is enveloped by *rakta*. From *śūkra* are derived bones, from bone the *māṃsa* and from these two i. e. bone and *māṃsa* develop *śrāyū* (tendon) and all other major and minor body parts alongwith *indriyas*. From *rakta* heart is formed, from heart the liver, from liver the spleen and from spleen the lungs. All these structures are attached to each other.

१. वातकेन त्वचेहै मांसं त्वगाश्रितं मतम् ॥ ४५॥

शुक्रश्लेष्माद्वयो मेदो रसोऽस्थिक्तसम्भवः। पित्ताश्रितं हृदयस्य वातकमयं यकृतं ॥ ४६॥

रक्तश्लेष्मासाश्रित उरुः कफरक्तश्लेष्ममयः स्त्रीहा कफक्तमयः पेश्यश्च ॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/४५, ४६, ४७)

Hārta says that skin is formed from *vāyu* and *rakta*. The *māṃsa* is supported (covered) by skin. *Melās* is formed from *śukra* and *śleśmā* and from *rakta* the *rasa* and *asthis* (bones) are formed. The abode of *pitā* is heart, the liver is flooded with *vāyu* and *rakta*. The *rakta*, *kapha* and *rasa* are situated in *urā* (thighs). The spleen is flooded with *kapha*, *rakta* and *śleśmā* and the *peśis* with *kapha* and *rakta*.

विमर्श (Comments)

यद्यपि उक्त विषय का आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से स्पष्टीकरण कठिन है पर महर्षि काश्यप द्वारा "प्रविष्ट बीज का रक्त से परिचयन" वर्णन उन ऋषियों की दिव्यदृष्टि का द्योतक है क्योंकि शुक्राणु स्त्रीबीज या रक्त में सम्पूर्ण रूप में प्रविष्ट हो जाता है। हारीत ने प्लीहा को कफ, रक्त एवं श्लेष्ममय माना है, कफ एवं श्लेष्म दोनों शब्दों के प्रयोग का स्पष्टीकरण कठिन है। यकृत तथा प्लीहा दोनों ही अङ्ग आधुनिक विज्ञान में भी रक्त-स्थान माने जाते हैं।

Any scientific explanation for above description is not possible. However, enveloping of *hija* (sperm) by *rakta* (ovum) given by Kāśyapa is very scientific, because head of sperm enters the ovum and its tail is resorbed, thus main part of sperm is practically enveloped by ovum. Hārta has mentioned that spleen is flooded with *kapha*, *rakta* and *śleśmā*, *kapha* and *śleśmā* being one entity are inexplorable.

गर्भ के स्त्रीकर, पुरुषकर एवं नपुंसककर भाव (Specific features depending upon sex of the fetus)

सन्ति खल्वसिम्न गर्भे केचिद्विज्ञा भावाः, सन्ति चानित्याः केचित्। तस्य य एवाङ्गावयवाः सन्तिष्ठन्ते, त एव स्त्रीलिङ्गं पुरुषलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा विभ्रति। तत्र स्त्रीपुरुषयोर् वैशेषिका भावाः प्रधानसंश्रया गुणसंश्रयाश्च, तेषां यतो भूयस्त्वं ततोऽन्यतरभावाः। तदथा—कसैब्धं भीरुत्वमवैशाराहं मोहोऽनवस्थानमथोगुरुत्वमसहंनं शैथिल्यं मार्दवं गर्भाशयबीजभासतथायुक्तानि चापराणि स्त्रीकराणि, अतो विपरीतानि पुरुषकराणि, उभयभागावयवा नपुंसककराणि भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ४/१४)

यथारवं च गर्भस्य पुंस्त्रीनपुंसकान्यतमलिङ्गानुरूपा एव भावा मनसि शरीरे च सन्तिष्ठन्ते। वैशेषिकलिङ्गमङ्गूरे तु यतो भूयस्त्वं ततोऽन्यतरता भावाः ॥ १४॥

तदथा कसैब्धं भीरुत्वमवैशाराहं मोहोऽनवस्थानमथोगुरुत्वमसहंनं शैथिल्यं मार्दवं गर्भाशयबीजभावास्तथा युक्ताश्चारे स्त्रीकरा भावाः। ततो विपरीताः पुंसकराः। सङ्कीर्णा नपुंसककराः ॥ १५॥

(अ० सं० शा० २/१४, १५)

गर्भ के कुछ नित्य (कर एवं चरणदि) एवं कुछ अनित्य (दन्त आदि) भाव होते हैं। गर्भ के नित्य भावों वाले अंगावयव ही स्त्रीलिंग, पुलिंग एवं नपुंसक लिंग के निर्धारक होते हैं, यथा उपस्थ रूप नित्यभाव स्त्रीलिंग बोधक, शेष, पुच्छा बोधक तथा उपस्थ एवं शेष के स्थान में केवल रस्त्र की उपस्थिति नपुंसक लिंग बोधक है। यद्यपि स्त्री के स्तन एवं पुच्छ के रमश्रु आदि तथा नपुंसक के दोनों प्रकार के अवयव जनमोपरात उत्पन्न होते हैं परन्तु इनके आश्रय स्थान उर एवं कपोलों से ही पुरुषों में रमश्रु आदि काल वय या उचित काल होने पर उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार से युक्त कपोलों से ही पुरुषों में रमश्रु आदि काल वय या उचित काल होने पर उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार पृथ्वी में गिरा हुआ शालि आदि का बीज ऋतु आने पर ही अंकुरित होता है। इस प्रकार जो अंगावयव व्यक्त रूप में

विवर्तमान रहते हैं वे ही स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक-लिंग के निर्माता होते हैं^१। स्त्री-पुरुष-निर्माणक ये विशिष्ट भाव प्रधान संश्रय (या आत्मसंश्रय) तथा गुण संश्रय (या शुक्र-शोणित में स्थित पञ्चमहाभूतों के आधार) में आते हैं, अर्थात् स्त्री-पुरुष-निर्माणक विशिष्ट भाव गर्भ में आत्मा, शुक्र एवं शोणित स्थित पञ्चमहाभूतों द्वारा लाए जाते हैं; एवं जिसको देव वश प्रधानता होती है (स्त्री लिंगादि भावों में जिस लिंग के भावों की) उस लिंग (के गर्भ) का निर्माण होता है। जैसे कसैब्ध, भीरुत्व, अवैशाराह, मोह, अनवस्थान, अधोगुरुत्व, असहन (सहन शक्ति का न होना), शैथिल्य, मार्दवं एवं गर्भाशय तथा बीजभाग (स्त्री बीज) से युक्ता आदि अन्य भाव स्त्रीकर भाव होते हैं। इनमें से कसैब्ध से अनवस्थान तक के भाव प्रधानसंश्रय तथा अन्य गुणसंश्रय होते हैं। इनसे विपरीत लक्षण पुरुषलिंग-कारक तथा दोनों प्रकार के भाव नपुंसककर होते हैं।

अष्टाङ्गसंहकार ने भी लिखा है कि गर्भ के पुरुष, स्त्री या नपुंसक में से किसी एक के अपने लक्षणों के अनुसार मन एवं शरीर में गुण स्थित होते हैं। इन विशिष्ट लक्षणों के मिश्रित होने पर अन्य भाव उत्पन्न होते हैं (अर्थात् भीरुत्व स्त्रीकर भाव एवं सहस्र पुरुषकर भाव के मिश्रित होने पर तीसरे अर्थात् समस्त्वभाव की उत्पत्ति होगी)। जैसे-कसीबाता, भीरुता, अनिपुणता, ममता, असहन (शरीर का सुदृढ़ न होना), अधोगुरुता (शरीर के निचले भाग का भारोपन), शैथिल्य (अंगों का शिथिल होना), मुटुता (शरीर का मुटु होना), गर्भाशय एवं बीज (स्त्रीबीज) एवं अन्य अवर्णित सभी (स्त्रीचेष्टादि) स्त्रीकर भाव हैं इनके विपरीत पुरुषकर तथा मिश्रित नपुंसककर भाव हैं।

Caraka and Cakrapāṇi say that there are certain permanent features in the body such as extremities etc. and certain temporary ones such as teeth etc. Permanent feature of fetus denote its specific female, male or hermaphrodite sex; for example permanent feature like vulva etc. denote female sex, penis etc. a male sex and absence of both but presence of just one aperture the hermaphrodite. Though breast (developed breast), moustache and beard etc. are conspicuous only after birth, yet, these are also permanent features because the chest and cheeks are permanent. The seed from which breast or hair of face would grow in chest of female and cheeks of male respectively are present from the very birth, without the presence of this initial seed these structures can not grow; these breast etc. develop at appropriate period (or age) in the same way as seed of *śāl* dropped in field will sprout only in its appropriate season. Only apparent permanent features denote specific sex. The features responsible for sex reside in *ātmā* (*pradhāna samśraya*) or *bhūtas* of *śukra* and *śonita* (*gūṇa samśraya*) and the formation of specific sex depends upon relative predominance of either of them. The features of female are—*klānya* (cowardice), *bhīrūva* (timorousness), *avaiśāradya* (lack of skill or fallibility), *moha* (mental confusion), *anavasthāna* (fickling nature), *adhogurūva* (heaviness of lower part), *asahana* (intolerance), *śaithilya* (laxity of

१. नित्या इति यावच्छरीरभाविनः कसचपादयः, अनित्याश्च न यावच्छरीरभाविनो दन्तादयः।। तत्रोपस्थरूपो नित्यो भावः स्त्रीलिङ्गं, शेषपुच्छं पुलिङ्गम्, उपस्थलिङ्गाकारविरहितं च रस्त्रभावं नपुंसकलिङ्गं भवति। किंच, स्त्रिया यद्विङ्गं स्तनादि, पुरुषस्य वा रमश्रुपुच्छं, नपुंसकस्य वा स्त्रीसुसमानाकाररूपं जालोत्तकालभावि, तदपि य एव नित्य भावा उरःकपोलभूतस्य एव कालवशाद्विभ्रती वाक्यार्थः। उर एव हि स्तनात्मकबीजयुक्तं स्त्रिया उत्तरकालं सनचक्रवति, एवं कपोल एव रमश्रुबीजयुक्तः रमश्रुवान भवति।यतो बीजमहिमाऽयं-यत् स्वकाल एव कार्यं करोति-यथा-अवनिपतितमपि शाल्यादीबीजमुपुच्छावैवाङ्गूरे जनयति। प्रधानसंश्रया इति आत्मसंश्रयाः, गुणसंश्रया इति शुक्रशोणितभूतसंश्रयाः, गुणशब्देनैवभूतानुच्यते।तेन यासिम्न वैशेषिके भावे भूयस्त्वं दैवत्वसङ्क्रवति। कसैब्धाराधनस्थानपर्यन्तं प्रधानसंश्रयं, शेषं गुणसंश्रयम्।। (च० सं० शा० ४/१४ की चक्र० टी०)

joins or body parts), *māṇḍava* (softness of body parts) and presence of uterus and *bija* (ovum) etc. Characters from *klāyivā* to *anāvasthāna* depend upon *pradhāna* or *ānānā* and others on *gūṇa* or *bhūtas* of sperms and ovum. Opposite to these are masculine characters and mixture of both belong to hermaphrodite.

Vāḍbhata I has also expressed almost similar view albeit in abbreviated form and has replaced intolerance with looseness.

गर्भ के जन्मोपरान्त उत्पन्न होने वाले अङ्गावयव (The body parts developing after birth)

येऽप्य जातस्योत्पत्तकालं जायन्ते; तद्यथा-दन्ता व्यञ्जनानि व्यक्तीभावस्तथायुक्तानि चापराणि । एषा प्रकृतिः,

विकृतिः पुनरतोऽप्यथा ॥ (च० सं० शा० ४/१४)

जन्मोत्पत्तकालजेभ्यो दन्तादिभ्यः क्रमेण तु स्पष्टीभवन्ति । एषा प्रकृतिः । विकृतिस्ततोऽप्यथा ॥

(अ० सं० शा० २/१३)

जो इस गर्भ के जन्मोत्तर काल में उत्पन्न होते हैं वे इस प्रकार हैं-दन्त, व्यञ्जन (दाढ़ी, मूछ, स्तनादि) का व्यक्तभाव तथा शुक्र एवं रज का प्रादुर्भाव^१ आदि बाद में होते हैं, यह प्रकृति है अन्यथा विकृति है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि दन्तादि की उत्पत्ति जन्मोत्तर काल में क्रमशः होती है यह प्रकृति है अन्यथा विकृति है । अर्थात् सदन्त-शिशु का जन्म एक विकृति है ।

उपर्युक्त वर्णन में टीकाकार ने व्यञ्जनादि एवं व्यक्तीभाव दोनों शब्दों को पृथक् करके अर्थ किया है पर ऐसा आपास होता है कि व्यक्तीभाव शब्द पूर्व के सभी अंगों जैसे दन्त-व्यञ्जनादि की व्यक्तता या स्पष्टता के लिए प्रयुक्त है अर्थात् दन्त, व्यञ्जन (श्मश्रु, स्तन, गुहाङ्ग के केशादि) सभी यद्यपि गूढरूप में विद्यमान तो रहते हैं परन्तु जन्मोत्तरकाल में समय आने पर व्यक्त या स्पष्ट होते हैं ।

Caraka says that teeth, moustache, beard, *śukra* (seminal ejaculate) and *raja* (menstruation) become conspicuous after birth, this is *prakṛti* (normalcy) otherwise it is (their presence from birth) pathology.

Vāḍbhata I has mentioned only teeth in this category.

गर्भ की वर्णोत्पत्ति के कारण (Factors for formation of body-complexion)

न खलु केवलमेतदेव कर्म वर्णवैशेष्यकरं भवति । अपि तु तेजोधातुराजस्रद्वन्द्वकान्तरिक्षधातुप्रायोऽवदातवर्णकरो भवति, पृथिवीवायुधातुप्रायः कृष्णवर्णकरः; समसर्वधातुप्रायः श्यामवर्णकरः ॥ (च० सं० शा० ८/१५)

तत्र तेजोधातुः वर्णानां प्रभवः; स यदा गर्भोत्पत्तावस्थातुप्रायो भवति तदा गर्भं गौरं करोति, पृथिवीधातुप्रायः कृष्णं, पृथिव्याकाशधातुप्रायः कृष्णश्यामं, तोयाकाशधातुप्रायो गौरश्यामम् यादृगवर्णमाहारमुपसेवते गर्भिणी तद्वर्णप्रसवा भवति इत्येके भाषन्ते ॥ (सु० सं० शा० २/३५)

तत्र शुक्रे शुक्ले धृतपण्डाभे वा गर्भस्य गौरत्वं तैलाभे कृष्णत्वं मध्वाभे श्यामत्वं । तथा क्षीरादिमधुराणां मधुरयोगान्मृदुदकविहाराच्च गौरता तिलाजविदाहिना कृष्णता व्यामिश्राणां श्यामता । देशकुलानुवृत्तितश्च वर्णभेदः । तथा तेजोधातोरदकाशधातुसम्पर्कद्वारात् भूवायुसम्पर्कात् कृष्णता सर्वधातुसाम्ये श्यामता ॥

(अ० सं० शा० १/६५)

१. व्यञ्जनानि श्मश्रुस्तनादीनि । व्यक्तीभावः शुक्ररजसोर्विभावः ॥ (च० सं० शा० ४/१४ की चक्र० टी०)

गर्भ के शरीर के वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए महर्षि चरक ने लिखा है कि केवल कर्म (पूर्ववर्णित पुष्टि यत्र) ही विशिष्ट वर्ण की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि तेज धातु जल एवं आकाशप्राय (जल एवं आकाश महाभूत की अधिकता से मिश्रित) होने पर गौर वर्ण कारक, पृथ्वी एवं वायु धातुप्राय होने पर कृष्ण वर्ण कारक एवं सभी धातुओं का साम्य होने पर श्याम वर्ण कारक होता है (अर्थात् प्रधान रूपेण तेज धातु ही वर्ण का निर्माणकर्ता है) ।

महर्षि सुश्रुत ने भी तेज धातु को प्रधान बताते हुए लिखा है कि तेज धातु सर्व वर्णोत्पत्ति का हेतु है गर्भोत्पत्ति के समय जब वह जल धातु प्रधान होता है तो गौर वर्ण, पृथ्वी धातु प्रधान्य में कृष्ण वर्ण, पृथ्वी एवं आकाश धातु प्रधान्य में कृष्ण-श्याम वर्ण एवं जल तथा आकाश धातु प्राधान्य में गौरश्याम वर्ण के गर्भ की उत्पत्ति करता है । अन्य आचार्यों का कथन है कि गर्भिणी स्त्री जिस प्रकार के वर्ण के आहार का सेवन करती है उस प्रकार के गर्भ की उत्पन्न करती है ।

महर्षि वाग्भट ने अष्टासंग्रह में गर्भ की वर्णोत्पत्ति के लिए चार कारणों का वर्णन किया है । शुक्र (पुरुष का शुक्र) के श्वेत, शूल या मण्डाभ होने पर गर्भ की गौरवर्णता, तैलाभ होने पर कृष्णवर्णता एवं मध्वाभ होने पर श्यामवर्णता प्राप्त होती है । (२) इसी प्रकार माता (गर्भिणी) के दुग्ध आदि मधुर द्रव्यों के (अधिक) उपयोग एवं जल विहार आदि करने से गर्भ की गौरवर्णता, तिल, अन्न आदि विदाही पदार्थों के सेवन से कृष्णवर्णता एवं मिश्रित आहार-विहार से श्यामवर्णता प्राप्त होती है । (३) देश, काल एवं अनुवृत्ति से भी वर्णभेद होता है । (४) तेज धातु के उदक एवं आकाश से सम्पर्क होने पर गौरवर्णता, पृथ्वी एवं वायु के सम्पर्क से कृष्णवर्णता एवं सभी धातुओं के साम्य से श्यामवर्णता होती है । टीकाकार इन्द्र ने सभी मिश्र भावों से वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन कर उपर्युक्त मतों का सामंजस्य स्थापित किया है ।

महर्षि हारीत ने शरीर वर्ण निर्माण में दोष-प्राधान्य का वर्णन दिया है इनके मत से वात से श्याम, पित्त से गौर, रसेभा से भी श्याम, वात-रक्त से कृष्ण, पित्त-रक्त से पिण्ड तथा कफ-रक्त से भी श्याम वर्ण का व्यक्ति होता है ।

The complexion of body does not depend only upon the influence of *pureṣṭi vyāñya* etc. rather it depends upon the *teja mahābhūta*. Different complexions arise on the basis of association of other *bhūtas* with *teja*. The opinions of authors are given here under.

Complexion	Responsible <i>bhūtas</i> or <i>doṣa</i>		
	Caraka and Vāḍbhata I	Suśruta	Hārīta
<i>Gaura</i> (fair)	<i>Teja</i> + <i>Jala</i> * + <i>Ākāśa</i> *	<i>Teja</i> + <i>Jala</i> *	<i>Pita</i>
<i>Kṛyua</i> (black)	<i>Teja</i> + <i>Prithvī</i> * + <i>Vāyu</i> *	<i>Teja</i> + <i>Prithvī</i> *	<i>Vāta</i> + <i>Rakta</i>
cont.			

१. तेषां चाहारविहारदेशकुलादिभूतविज्ञानां परस्परानाविधभेदविज्ञानां मिश्रिभावेन वर्णानां मानम् ।

(अ० सं० शा० १/६५ की इन्द्र टी०)

२. वातेन श्यामः पित्तेन गौरः । रसेष्वा जायते श्यामश्च ।

वातरक्तेन कृष्णोऽपि पित्तरक्तेन पिङ्गलः । श्यामः कफसृज ॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/३१, ३२, ३३)

	Caraka and Vāgbhata I	Suśruta	Hārīta
Śyāma (swarthy)	All bhūtas equal	—	Vāta and kapha**
Gaurasvāma	—	Teja+ Jala*+ Ākāśa*	— & Rakta*+Kapha
Kṛṣṇasvāma	—	Teja+ Prithvi*+ Ākāśa*	—
Piṅgla (tawny)	—	—	Pitta+Rakta

*dominant bhūta; **both these independently

Besides this Suśruta quoting the views of others says that the colour of diet (used by the mother) also influences the complexion. Vāgbhata I elaborates further that (1) if semen is white or has the colour of *ghee* or *manāda* (the scum of boiled rice) the complexion would be fair; if semen resembles oil in colour then dark and if it is honey coloured then complexion would be swarthy, (2) similarly if pregnant woman has used milk etc. sweet substances and bathing or swimming then the complexion would be fair; if black *tila* etc. *vidāhi* (producing burning sensation or pungent or acrid) substances then dark and if mixture of diet then swarthy, (3) complexion also depends upon *dēśa* (place of living), *kula* (race or family) and also mode of livelihood. Indu says that all the factors together play a role in the formation of complexion of the body.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन में सभी आचार्यों ने शरीर के वर्ण निर्माण में तेज धातु का ही प्राधान्य माना है। महर्षि सुश्रुत ने आहार के वर्ण का तथा वायु ने अन्य देशादि के ही साथ शुक्र के वर्ण का भी प्रभाव गर्भ की वर्णोत्पत्ति में माना है। अन्यत्र वर्णित शुद्ध शुक्र के लक्षणों में सभी आचार्यों ने श्वेत वर्ण शुक्र को ही शुद्ध माना है अतः इन विभिन्न वर्णों की कल्पना का स्पष्टीकरण कठिन है क्योंकि ये वैकारिक वर्ण हैं। महर्षि सुश्रुत ने सम्भवतः निवास-स्थान के भेद के कारण गौर, कृष्ण एवं रस्यम वर्ण के बीच के कृष्णरस्यम एवं गौररस्यम वर्णों को भी कल्पना की है। महर्षि हारीत ने भी सुश्रुत सदृश ही अनेकों वर्णों की कल्पना की है।

Vāgbhata I has described that complexion of body is also influenced by colour of semen, while he himself has described only white colour of healthy semen, naturally these colours become pathologic, and it is not possible to offer any explanation for this description. The concept of more than three complexions by Suśruta and Hārīta denotes probably their living areas, wherein these might be prevalent.

गर्भ की जालन्धता एवं नेत्र की वर्णोत्पत्ति का कारण (Cause of congenital blindness and formation of colour of eyes)

तत्र दृष्टिभागमप्रतिपन्नं तेजो जालन्धं करोति, तदेव रक्तानुगतं रक्ताक्षं, पित्तानुगतं पिङ्गाक्षं श्लेष्मानुगतं शुक्लाक्षं, वातानुगतं विकृताक्षमिति॥ (सु० सं० शा० २/३५)

अपि च-दृष्टिभागमप्रतिपन्नं तेजो जालन्धत्वं तदेव वातानुगतं विकृतरक्षणाक्षं पित्तानुगतं पिङ्गाक्षं श्लेष्मानुगतं शुक्लाक्षं रक्तानुगतं रक्ताक्षमिति॥ (अ० सं० शा० २/५७)

यदि दृष्टि-भाग में तेज धातु न पहुँचे तो वह जालन्ध (बालक की उत्पत्ति) करता है, वही तेज रक्तानुगत होने पर रक्ताक्ष, पित्तानुगत होने पर पिङ्गाक्ष, श्लेष्मानुगत होने पर शुक्लाक्ष एवं वातानुगत होने पर विकृताक्ष उत्पन्न करता है। टीकाकार डल्हण ने जालन्धता की उत्पत्ति में पूर्वजन्म के कर्म की प्रधानता मानते हुए दृष्टिभाग में तेज के पहुँचने का काल गर्भ का चतुर्थ मास बताया है। अन्यत्र दौहद-अवसर्जन से भी विकृताक्ष या अनक्ष (अक्ष विरहित) शिशु की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

अष्टांगसंग्रहकार ने सुश्रुत सदृश ही वर्णन किया है कि यदि तेज धातु दृष्टिभाग में न पहुँचे तो जालन्ध, उसी (तेज) के वातानुगत होने पर विकृत, रक्ष एवं अरुणक्ष; पित्तानुगत होने पर पिङ्गाक्ष, श्लेष्मानुगत होने पर शुक्लाक्ष एवं रक्तानुगत होने पर रक्ताक्ष गर्भ की उत्पत्ति होती है।

उपर्युक्त दोनों ही आचार्यों ने नेत्रों के विभिन्न आकार एवं वर्ण की उत्पत्ति में तेज धातु का प्रधान्य माना है।

Suśruta and Vāgbhata I have written that if *teja dhātu* does not reach eyes, the born child would be *jāyandha* (congenitally blind). If the *teja* is followed by *rakta* then the colour of eyes would be red, if by *pitta* then yellowish, if by *śleṣmā* then white and if by *vāyu* then the eyes would be dry, pink and abnormal in shape and size (*vikṛta*). Dāhāna explains that the deeds of previous life prevent the entry of *teja* in eyes, the period for which is 4th month of gestation. At another place Suśruta has said that non-fulfilment of *dauhyāda* results in either abnormal shape of eyes or their absence.

गर्भ के तिङ्ग-निर्माण के कारण (Factors for sex formation)

रकेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्लेण.....॥ (च० सं० शा० २/४२)

तत्र शुक्रबाहुल्यात् पुमान्, आर्तवबाहुल्यात् स्त्री, साम्यादुभयोर्नपुंसकमिति॥ (सु० सं० शा० ३/५)

तत एव च शुक्रस्य बाहुल्यात्पुमान्, आर्तवस्य बाहुल्यात्स्त्री, तयोः साम्येन नपुंसकम्॥

(अ० सं० शा० २/५)

अत एव च शुक्रस्य बाहुल्याज्जायते पुमान्।

रक्तस्य स्त्री, तयोः साम्ये क्लीबः.....॥ (अ० सं० शा० १/५)

रक्त की अधिकता से कन्या एवं शुक्र की अधिकता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। अन्यत्र महर्षि चरक ने स्त्री एवं पुत्र की उत्पत्ति में हेतु की प्रधानता वर्णित करते हुए स्पष्टीकरण दिया है^१ कि दोषरहित सुन्दर बीज खेत में बोने पर अपनी प्रकृति के अनुसार धान से धान, जौ से जौ के रूप में अंकुरित होता है, उसी भाँति स्त्री एवं पुरुष हेतु के अनुसार (शुक्र या रज की अधिकता के अनुसार^२) विभक्त होते हैं।

१. चतुर्थ मासि कस्यचित् पूर्वकर्मवशात् दृष्टिभागं चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठानम् अप्रतिपन्नम् अप्राप्तं तेजो जालन्धं जन्मान्वं करोति॥ (सु० सं० शा० २/३५, की डल्ह० टी०)

२. सु० सं० शा० ३/१८ (दौहद अपूर्ति-परिणाम के अन्तर्गत उद्धृत)

३. एवमभिनिर्वर्तमानस्य गर्भस्य स्त्रीपुरुषत्वे हेतुः पूर्वमुक्तः। यथा हि बीजमनुगतमग्नं स्वां स्वां प्रकृतिमनुविधीयते व्रीहिर्वा व्रीहित्वं यवो वा यवत्वं तथा स्त्री पुरुषावपि यथेकं हेतुविभागानुविधीयते॥ (च० सं० शा० ८/१८)

४. हेतु विभागानुविधीयते इति "रकेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्लेण" इत्यादि। (च० सं० शा० ८/१८ की चक्र० टी०)

मङ्गलिं सुश्रुत ने भी शुक्र के बाहुल्य से पुरुष एवं आर्तव के बाहुल्य से स्त्री एवं त्रिंशों के समान होने से नपुंसक की उत्पत्ति मानी है। अष्टांगसंग्रह एवं अष्टांगहृदयकार के भी यही विचार है।

टीकाकार अरुणदत्त ने स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि संभोग के समय यदि पुरुष पहिले विसर्जित हो तो वीर्यवान पुत्र, यदि स्त्री पहिले विसर्जित हो तो रूपवती कन्या उत्पन्न होती है। इसी कारण से ही कृत्रु पुंमर्ष मातृ सद्गुण तथा स्त्रीगर्भ पितृ सद्गुण भी होते हैं अर्थात् यदि शुक्राधिक्य का पुंमर्ष है पर स्त्री पूर्व विसर्जित हुई तो मातृ सद्गुण पुंमर्ष, इसी प्रकार यदि रजोधिक्य होने पर भी पुरुष पहिले विसर्जित हो तो पितृसद्गुण कन्या गर्भ होगा।

टोकाकार डल्हण ने आर्तव एवं शुक्र के बाहुल्य का स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न करते हुए लिखा है कि यों तो आर्तव चतुर्जालि प्रमाण एवं शुक्र एक प्रसूति मात्र होता है अतः आर्तव का तो बाहुल्य हर समय रहेगा, पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर गर्भाशय स्थित मल-गहित गर्भजनक आर्तव की मात्रा का ग्रहण करना चाहिए; अथवा स्वमान (अपने अपने सामान्य मान) के आधार पर बाहुल्य का ग्रहण करना चाहिए। शुक्र कभी कभी हर्ष आदि के कारण मात्रा में अधिक आ जाता है एवं कभी कभी मानसिक ग्लानि से मात्रा कम हो जाती है। अन्य आचार्यों के मत को उद्धृत करते हुए शुक्र एवं आर्तव के प्रमाण को न लेकर उसमें स्थित वीर्य या कार्थरीक की अधिकता को कारण स्वरूप बताया है।^१

आचार्य भवमिश्र ने अन्य आचार्यों सद्गुण ही शुक्र की अधिकता से पुत्र एवं आर्तव की अधिकता से कन्या की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए टीकाकार डल्हण द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया है, जिसमें शुक्र के अत्यधिक मात्रा में क्षरण के लिए दुग्धादि शुक्रल द्रव्य-सेवन एवं शुक्र की ही भाँति आर्तव की भी मात्रा के प्रभावित होने का उल्लेख किया है तथा गर्भाशय-स्थित शुक्र या रज की ही अधिकता या न्यूनता को लिंग-निर्णायक माना है। साथ ही सुश्रुत के वाक्य को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया है कि शरीर के दोषादिकों की मात्रा स्थिर नहीं होती, क्योंकि शारीरिक विलक्षणता अर्थात् दीर्घ (लम्बे), ह्रस्व (छोटे) एवं कृश आदि भेदों के कारण शरीरों का सद्गुण न होने से एव वय, अहोरात्रि, ऋतु एवं भुक्तव्या आदि में दोषों की अस्थिरता होने से इनकी मात्रा में परिवर्तन होता है, अर्थात् शुक्र एवं आर्तव की एक प्रसूति या चतुर्जालि प्रमाण कोई निश्चित मात्रा नहीं है, यह अवस्था-विशेष से परिवर्तित होती है, जिसके कारण पुत्र या पुत्री का जन्म होता है।^२

१. दारुकाहिना वृकम्-

स्त्री पुंसंयोरु संधोगे यद्यदा विसृजेतुमन्। शुक्रं, ततः पुमान् वीरो जायते बलवान् दृढः।

अथ चेद्विना पूर्वं विसृजेदकसंयुतम्। ततो रूपान्विता कन्या जायते दुर्दसंहता ॥ इति॥

अत एव च पुंमर्षाः केवलिकाश्चिमातृसद्गुण दृश्यन्ते, स्त्रीमर्षाश्च केवलिकाश्चित्पुंसद्गुण दृश्यन्ते ॥

(अ० ह० शा० १/५ की अरुण० टी०)

२. ननु शुक्रबाहुल्यत्वात् पुमान् इति कस्मादुक्तम्? यत् आर्तवस्यैव बाहुल्यम्; 'उक्तं हि-आर्तवं हि चतुर्जालिप्रमाणं, शुक्रन्तु प्रसूतिमात्रम् इति', नैवं, यावन्मात्रमार्तवं गर्भाशयवस्थितं मलरहितं गर्भजननं तावदेव ग्राह्यम्; अथवा स्वप्रमाणपेक्षया शुक्रगोणितयोर्बाहुल्यमन्तत्वं चाभिप्रेतम्। शुक्रं तु कदाचिदन्तर्हर्षवशात् बहु स्रवति, कदाचिद् वैमनस्यादल्गतिरिति। अन्ये त्वाचार्या एवं ब्रूवन्ति-शुक्रार्तवयोर्न्याधिकसमत्वं वीर्येण भवति। (सु० सं० शा० ३/५ की डल्ह० टी०)

३. अधिक्ये रेतसः पुत्रः कन्या स्यादातर्वेऽधिके। नपुंसकं तयोः साम्ये यथेच्छा पापमेधरी ॥

नन्वेवं सति कथं पुत्रोत्पत्तिः सर्ववार्तवस्यैव बाहुल्यत्वात्। यत् उक्तम्- 'आर्तवं चतुर्जालिप्रमाणं शुक्रं प्रसूतिमात्रम्' इति। ... नैवं यतो गर्भाशयस्थमेव शुक्रमार्तवं च गर्भोत्पत्ति हेतुः, शुक्रं कदाचिदन्तर्हर्षवशाद् दुग्धादिशुक्रलद्रव्यसेवनात्

शुक्रबाहुल्यत्वाद् गर्भाशये बहु स्रवति कदाचिद्वैमनस्यादिना शुक्राल्पत्वाच्चल्गतिरिति, एतमार्तवमपीति न दोषः॥ सुश्रुतः पुराह- 'वैलक्षण्याच्छरीरगामस्यादितार्तवे च। दोषश्चातु मलानां तु परिमाणं न विद्यते' ॥

वैलक्षण्यात् दीर्घह्रस्वकृशादिभेदेन सद्गुणगणनाद् अस्यादितत्वात् वयोऽहर्निशतुर्पुकेच्छेकमानागवस्थानात् ॥

(पा० प्र० पूर्व० ३/४०)

महर्षि भेल ने भी शुक्राधिक्य से पुत्र एवं शोणित्वाधिक्य से कन्या की उत्पत्ति मानी है। अन्यत्र संभोग के समय पुरुष के सर्वाङ्ग नन्दित होने तथा स्त्री के जघन्य होने से पुरुष के अंग-प्रत्यंग सद्गुण तथा स्त्री के प्रथम अर्ध-साधन एवं पुरुष के जघन्य होने से स्त्री के अंग-प्रत्यंग सद्गुण सत्त्वान की उत्पत्ति मानी है।^१

योगरत्नाकरकार ने दक्षिण नाड़ी से पुत्र एवं वामनाड़ी से कन्या की उत्पत्ति का वर्णन किया है, साथ ही रक्ताधिक्य से कन्या, शुक्राधिक्य से पुरुष एवं दोनों के मिश्रण अर्थात् साम्य से नपुंसक की उत्पत्ति मानी है।^२ (यहाँ पर वाम या दक्षिण नाड़ी डिव्यग्रन्थि का होतक मानना चाहिए क्योंकि सामान्यतया दक्षिण डिव्यग्रन्थि से आया हुआ बीज दक्षिण डिव्यग्रणाली या नाड़ी से एवं वाम डिव्यग्रन्थि से आया हुआ बीज वाम डिव्यग्रणाली से आया)।

महर्षि हारीत ने भी अन्य आचार्यों के सद्गुण शुक्र एवं रज की न्यूनता एवं अधिकता को ही लिंग-निर्माणकारक माना है, परन्तु इन्होंने स्त्री एवं पुरुष दोनों में ही रेतस् की उपस्थिति शुक्र एवं रज से भिन्न मानी है, तथा ईन्द्रिय की कमी अर्थात् संभोग-शक्ति का भी लिंग-निर्माण में प्रभाव माना है। इन्होंने लिखा है कि यदि पुरुष का रेतस् अथवा शुक्र अधिक हो या (स्त्री का) रस (रज या पोषण)^३ या ईन्द्रिय (संभोग-शक्ति) न्यून हो तो अधिकांशतः पुरुष (पुत्र) की उत्पत्ति होती है। स्त्री के रेतस् के अधिक होने से अथवा शुक्रेन्द्रिय (संभोग-शक्ति या शुक्र तथा ईन्द्रिय या पुरुष की संभोग-शक्ति) हीन होने से या रज के अधिक होने से स्त्री (कन्या) की उत्पत्ति होती है जब वीर्य एवं रज समान हों तो पुरुष सम प्रकृति का अर्थात् न वह स्त्री न पुरुष होता है जो न स्त्री हो न पुरुष उसे नपुंसक कहते हैं। दोष एवं बल (पति पत्नी के) तथा प्रकृति एवं विकृति समान हो तो शुक्र एवं रज से नपुंसक स्त्री उत्पन्न होती है।^४

आचार्य शार्ङ्गधर ने परमेधर की इच्छा की प्रधानता बताते हुए रज की अधिकता से कन्या तथा शुक्र की अधिकता से पुत्रोत्पत्ति अन्य सभी आचार्यों सद्गुण ही मानी है।^५

Sex of the child depends upon relative predominance of *śukra* or *raja* i.e. if *śukra* is more then the fetus would be a male and if *raja* then a female. Caraka has further explained that as a healthy seed after sowing sprouts and grows according to its own character, such as the paddy seed will grow as paddy a barley seed only as barley, similarly male or female are born according to dominance of *śukra* or *raja* respectively.

१. (अ) भवत्यध्याधिके शुक्रे पुरुषः, शोणितोऽङ्गना। नपुंसकं तु(त)योस्साम्ये तस्मान्छुक्रं विवर्धयेत्॥ (शे० सं० शा० ३/८)

(आ) तदा(दि)ह सक्त(वि)पतितयोर्वै पुरुषस्सर्वमर्ध(वै) नन्दयति जघन्यं स्त्री, तत्र पुमान्(नि)नैवाङ्गप्रत्यङ्गैस्सद्गुणो जायते।

यत्र तु स्त्री प्रथममर्धं साधयति जघन्यं पुरुषः, तत्र स्त्री(रे)वाङ्गप्रत्यङ्गैस्सद्गुणो(शी) जायते। (शे० सं० शा० ५/१०)

२. वामनाड्या भवेत् कन्या पुत्रो दक्षिणया भवेत्। रक्तोऽधिके भवेत्कन्या पुत्रः शुक्रोऽधिके भवेत् ॥

शुक्रगोणितमिश्रेण भवेत्सौ नपुंसकः ॥ (यो० र० योनिव्या०)

३. 'रस' शब्द के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक पोषण आदि विषय विचारणीय नहीं है अतः यहाँ पर रस के स्थान में 'रज' शब्द होना चाहिए।

४. नरेतोऽधिकत्वेन तथा शुक्राधिकेन तु। हीन स्रोत्रैवापि जायते पुरुषाधिकः ॥ २६॥

स्त्री रेतसोधिकत्वेन हीनशुक्रेन्द्रियादि। रजसोऽधिकत्वेन स्त्रीसम्पूतिः प्रजायते ॥ २७॥

समबोर्धनजस्तन नरः स्त्रीप्रकृतिर्भवेत्। नपुंसकमिति ख्यातं न स्त्री न पुरुषो वेदेत् ॥ ३७॥

समदोषबलेनापि प्रकृत्याविकृतेरपि। शुक्रासृक्त्वं यवेच्छ्यामा नपुंसकं समुद्रवा ॥ ४०॥

(शे० सं० षष्ठस्थान १/२६, २७, ३७, ४०)

५. आधिक्ये सत्त्वः कन्या पुत्रः शुक्राधिके भवेत्। नपुंसकं समत्वेन यथेच्छा पापमेधरी॥ १२॥ (शा० सं० पूर्व० ६/१२)

Arjunadatta has mentioned that if the man first ejaculates (after the peak of orgasm) the fetus would be male, if the female excretes first then the child would be a female. Due to this very cause some of the male children have maternal characters while the females paternal or in other words if there is predominance of *śukra* but female excretes first or her orgasm perishes earlier than male the born male child will have characters of mother and vice versa.

Dalharna has advanced the explanation for predominance of *śukra* and *ārtava*. He says that *ārtava* is four *āṅgali* and *śukra* one *prasthi* in quantity or *ārtava* will always be more in quantity than *śukra*, but it is not so, here the quantity of pure *ārtava* situated in uterus responsible for fertilization should be considered. However, occasionally due to over excitement etc. the quantity of ejaculated *śukra* (semen) may be more, or due to psychological depression it may be less which influences relative amount of *śukra* and *ārtava*. Citing the opinions of others he has mentioned that instead of amount the functional potency of *śukra* and *ārtava* influences the formation of sex.

Bhāvanīśra corroborating the above views adds that the quantity of *doṣas* etc. of the body is unstable. Age, day, night, season and stage of food consumption etc. influence their quantity or the quantity of *śukra* and *ārtava* may change due to above reasons.

Yogarathnākara besides giving the importance of predominance of *śukra* and *ārtava*, has mentioned that from *dakṣiṇa nāḍī* (right ovary) the male child is born and from left the female.

Hārīta says that if *retas* and/or *śukra* of male is more and *raja* and *indriyas* (sexual power) of female is less then male child would be born and if *retas* and/or *raja* of female is more and *śukrendriya* (seminal ejaculate and sexual power) of male is less then female child would be born. If *śukra* and *raja* are equal then hermaphrodite will be born. If *doṣas*, *balla* (strength), *prakṛti* and *vikṛti* (physiopathology) of both male and female are equal then from *śukra* and *raja* a female hermaphrodite would take birth.

Śaṅgadhara says that besides role of *śukra* and *ārtava*, the will of god is responsible for formation of sex.

गर्भ के कार्य (Functions of garbha)

गर्भो गर्भलक्षणम् ॥ (सु० सं० सू० १५/५)

गर्भ गर्भ के लक्षणों (स्त्रियों की स्त्रावमुखादि^१) का उत्पन्नक होता है ।

Garbha produces its own signs such as blackening of areola etc.

बहुपत्यता (Multiple pregnancy)

(१) बहुपत्यता का कारण (Factors responsible for multiple pregnancy)

भिनति यावद्बहुधा प्रपन्नः शुक्रार्तव वायुरतिप्रवृद्धः ।

१. गर्भो गर्भलक्षणमिति स्तनयोः श्यावमुखता इत्यादिक्, करोति इत्यध्याहारः (सु० सं० सू० १५/५ की डल्ल० टी०)

तावत्पत्यपत्यानि यथाविभागं कर्मात्मकान्यस्ववशात् प्रसूते ॥ (च० सं० शा० २/१४)

बीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने द्वौ जीवौ कृक्षिमागते ।

यमावित्तिभिधीयते धर्मैरतुरःसौ ॥ (सु० सं० शा० २/३७ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/३९)

शुक्रार्तवेऽनिलेन खण्डयो भिन्ने यथाविभागमपत्यानामुत्पत्तिः ॥ (अ० सं० शा० २/६)

..... शुक्रार्तवे पुनः ॥५॥

वायुना बहुभ्यो भिन्ने यथास्वं बहुपत्यता ॥६॥ (अ० सं० शा० १)

एकमेव हि तद् बीजं भिन्नं वायुबलद्वय ॥ (का० सं० क० ६/५९)

(गर्भाशय में आए हुए) शुक्रार्तव को वहाँ की अत्यन्त बड़ी हुई वायु जितने अधिक भागों में विभक्त करती है उतनी ही सन्तानें उत्पन्न होती हैं। यह कार्य पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार होता है, स्त्री का अपना कोई वश नहीं होता ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि अन्तर्गत वायु (गर्भाशयान्तर्गत अथवा शुक्रार्तवान्तर्गत) द्वारा बीज (शुक्रार्तव-संयुक्त) के भिन्न (दो में विभक्त) होने पर दो बीज कुक्षि में आते हैं, वे धर्मैर-तुरःसः अर्थात् धर्माधर्मजन्य यमज कहलाते हैं । टीकाकार डल्लण ने गयी के वाक्य को उद्धृत करते हुए अधर्म से ही यमलोत्पत्ति मानी है तथा श्रुति, स्मृति के आधार पर प्रामाणिक करने का भी उल्लेख किया है^१ ।

अष्टाङ्गसंग्रह एवं अष्टाङ्गहृदयकार ने वायु की प्रधानता बताते हुए लिखा है कि वायु के द्वारा शुक्रार्तव का जितने खण्डों में विभाग होगा उतने ही अपत्तियों की उत्पत्ति होगी, टीकाकार इन्द्र ने भी इसका समर्थन किया है^१ ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि बीज एक ही होता है उसे वायु (दो में) भिन्न कर देती है ।

महर्षि भेल ने वायु द्वारा कलल का विभाजन यमल-गर्भ को उत्पत्ति का कारण माना है एवं कुते तथा वराह का उलहरण देते हुए बहुपत्यता का भी वायु ही कारण माना है^१ ।

महर्षि हारीत ने सभी आचार्यों से भिन्न एक अन्य ही कारण यमल को उत्पत्ति का दिया है इनका कहना है कि दोष एवं धातु के विशिष्ट प्रकार के संयोग से अंग (गर्भ में अंग-प्रत्यंग) का निर्माण सम्भव होता है । जब (पति-पत्नी) भ्रत-चित्त होकर सम्भोग करते हैं, तो दोनों से (दोष-धातु के प्रभाव एवं भ्रत-चित्तता) से मन द्रवता है (अस्थिर होता है), तब यमल की उत्पत्ति देखी जाती है, जो (यमल) अन्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाला है^१ ।

Excessively increased *vāyu* situated in the uterus divides the *śukrārtava* (combination of sperms and ovum) in multiple pieces. Number of fetuses corresponds to the number of

१. धर्मैरतुरःसौ धर्माधर्मपुराणिनी । गयी तु धर्मैरतेऽधर्मः ततुरःसौ अधर्मपुराणिनी न तु धर्माधर्मतुरःसौ । यतः श्रुतस्मृतिव्यावर्तित्वं यमोत्पत्तिरीष्टा; अतएव तदुत्पत्तौ प्रायश्चित्तमप्युपदिष्टमिति व्याख्याति ॥ (सु० सं० शा० २/३७ की डल्ल० टी०)

२. मिश्रीभूतं च शुक्रार्तव स्वविशिष्टैरुकोऽनिलो यदा खण्ड्यः करोति तदा बहुनामपत्यतायां संभवः ॥ (अ० सं० शा० २/६ की इन्द्र टी०)

३. यदा तु कललं वायुस्तं द्विधा कुरोते बली । यमौ तदौ (दा) संभवतः कृष्णोयववो यथा ॥ ९॥

वायुस्त्वक्षयग्रहणां (वायुस्तु क्षयग्रहणां-शु० पा०) देहेषु बलवान् पुनः ।

स तत्र कललं भित्त्वा करोति बहुपत्यम् ॥ ११॥ (शु० सं० शा० ३/९ व ११)

(अक्ष को एकबार में एक ही बच्चा पैदा होता है जब कि कुते को अनेक, अतः पाठ शोध किया गया है ।

४. दोषधातुविशेषण सङ्गे सत्यङ्गसंभवः । कृत भ्रान्ते च संभोगे द्वाभ्याश्च द्रवते मनः ॥ दृश्यते यमलोत्पत्तिरित्यन्तिप्रियङ्करी ॥ (हो० सं० षष्ठस्थान १/३८, ३९)

pieces. This act (of division by *vāyu*) is guided by deeds of previous life and is beyond the control of woman.

Suśruta says that when *vāyu* divides this *bija* in two pieces, the two *jīvas* come there, this depends upon religious and non-religious virtues.

Division of *bija* by *vāyu* has been described by both Vāgbhāṣas and Kāśyapa and of *kalā* by Bhela.

Hārta opines that origin of all fetal parts depends upon specific combination of *doṣas* and *dhātus*. When husband and wife copulate with fickle mind, then because of instability of mind (which influences the *doṣas*) the twins are born, which are a source of amusement to others.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सभी आचार्यों ने यमल गर्भ की उत्पत्ति में एक ही बीज का वायु द्वारा खण्डों में विभाजित होना माना है अर्थात् आधुनिक दृष्टि से इनको एक बीजात्मक यमल (युनिओयुलर दिवन) कहा जा सकता है। महर्षि सुश्रुत ने यद्यपि दो जीवों का भी आगमन माना है, पर प्रारम्भ में एक ही बीज का विभाग वर्णन किया है। इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य घणोकर जी ने 'भिन बीजे' से दो अर्थ किए हैं (१) दो भिन-भिन बीज जिनसे द्विबीजात्मक यमल की उत्पत्ति (वाइओयुलर दिवन) होती है (२) एक ही बीज के भिन होने से अर्थात् एक बीजात्मक यमल की उत्पत्ति (युनिओयुलर दिवन) होती है।

All the classics have described division of seed or have described only uniovular twins. Though Suśruta has mentioned arrival of two *jīvas*, yet has also accepted initial division of one *bija*. Explaining this particular verse Dr. Ghāṇekar has said that this denotes (1) two separate seeds or binovular twins and (2) division into two of one seed or uniovular twins.

(२) युग्म गर्भ के सुख दुःख आदि समान होने का कारण (Why happiness and sorrow etc. are identical in twins)

समानकर्मकत्वात् प्राङ्मांडीकत्वं च जन्म च ॥५९॥

तुल्यं निषेकाद् वृद्धेश्च जन्मनः स्तनसेवनात्। तस्मात्तुल्यं वयः प्रोक्तं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥६०॥

लक्षणाकृतिवर्णाङ्गबलप्रकृतिगुल्यता ॥ न तु तुल्यविसर्गाणां पृथगभावात् समानता ॥६१॥

(का० सं० क० ६/५९ से ६१)

एक नाभिज होने पर भी यमल पुत्रों की समानता एवं असमानताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि समान कर्म (वायु द्वारा विभाजन आदि), नाड़ी (गर्भ-वृद्धिकारक रस वहा-नाड़ी) एवं जन्म दोनों के एक से ही होते हैं। निषेक प्रभृति (गर्भाधान प्रभृति) से लेकर सम्पूर्ण गर्भ-वृद्धि एवं जन्म से ही स्तन-सेवन आदि तुल्य या एक सदृश होने से आयु, सुख, दुःख, भव (आरोप्य), अपभव (रोग), लक्षण, आकृति, वर्ण, अंग, बल एवं प्रकृति आदि में समानता होती है; परन्तु दोनों के पृथक् होने से उनकी तुल्य (पौषण) एवं विसर्ग (मल-मूत्रादि का विसर्जन) समान नहीं होती।

Explaining the similarities and dissimilarities of children born from one *nābhi* (placenta or uniovular twins) Kāśyapa says that due to similarity in *karma* (division by *vāyu*),

१. सु० शा० २/३७ डा० घणोकर टीका

२. एकनाभिकयोः कस्मात्तुल्यं मरणजीविमौ रोगोत्पत्त्यं सुखं दुःखं न तु तुल्यः समानता ॥ (का० सं० क० ६/५८)

presence of only one *nābhi* (*rasavadhā-nābhi* here placenta should be taken, because umbilical cords of twins are always separate), similarity in birth, similarity in nourishment during intrauterine life i. e. from the day of conception upto full term development and similarity and equality in lactation after their birth, their longevity, happiness, sorrow, health, illness, character, features, complexions, body parts, strength and nature are identical. However since they are two different individuals, thus, their nourishment and excretion (of feces, urine etc.) differs.

(३) युग्म (यमल) में दोनों ही पुत्र या पुत्री होने का कारण (Cause of specific sex in a twin pregnancy)

रतेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्रेण तेन द्विविधोक्तेन।

बीजेन कन्यां च सुतं च सूते यथास्वबीजाभ्यन्तराधिकेन ॥

शुक्राधिकं द्वैधमुपैति बीजं यस्याः सुतौ सा सहितौ प्रसूते।

रत्नाधिकं वा यदि भेदेनेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते ॥ (च० सं० शा० २/४२, ४३)

रक्त की अधिकता से कन्या एवं शुक्र की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है। जब (शुक्रार्तव मिश्रित) बीज को वायु दो भागों में विभक्त करती है तो कन्या एवं पुत्र का जन्म बीज में उस भाग की अधिकता से होता है, अर्थात् बीज के जिस भाग में शुक्र की अधिकता होगी उससे पुत्र एवं जिसमें आर्तव की अधिकता होगी उससे कन्या की उत्पत्ति होगी। जब वायु बीज का इस प्रकार विभाग करती है कि दोनों में शुक्र की ही अधिकता होती है तो दो पुत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जब वायु बीज का ऐसा विभाग करती है कि दोनों में रक्त की ही अधिकता हो तो दोनों कन्याएं उत्पन्न होती हैं।

सु०सं० की पादटीका में उद्धृष्ट अधिक श्लोकों में लिखा है कि मिश्रीभाव अर्थात् संभोग के समय यदि पुरुष का अधिक एवं निर्मल रेतस् होता है तब गर्भिणी स्त्री दो बालकों का प्रसव करती है एवं यदि स्त्री बहु-शुक्रा होती है तो दो कन्याओं का प्रसव होता है। इसमें कोई संशय नहीं है।

आचार्य भेल ने भी शुक्राधिक भाग से पुत्र एवं रक्ताधिक भाग से कन्या की उत्पत्ति मानी है^३।

टीकाकार अरुणदत्त ने महर्षि चरक के मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि शुक्राधिक्य के गर्भ का वायु द्वारा विभाजन करने पर पुमान पुत्र तथा रजसाधिक्य-गर्भ के वायु द्वारा विभाजन से कन्या की उत्पत्ति होती है^३।

Charaka says that due to relative predominance of *rakta* the female child is born and of *śukra* the male child. The birth of male or female child in a twin pregnancy depends upon the manner in which *vāyu* divides the *bija* (zìgote), if *vāyu* divides the *bija* in such a way that one part has predominance of *śukra* and the other of *rakta* then from former part a

१. अस्याग्ने ता० पुस्तके

मिश्रीभावे यदा पुंसां रेतस् बहु निर्मलम्। तदा प्रसूयते नारी गर्भिणी दारकद्वयम् ॥

मिश्रीभावे स्याद्वैव बहुशुक्रं यदा भवेत्। कन्याद्वयं तदा नारी सूयते नात्र संशयः ॥ इत्यादिकः पाठ उपलभ्यते ॥

(इत्थं टीका युक्त चौ० ओ० द्वारा प्रकाशित सु० सं० शा० २/३७ की पाद टीका)

२. तत्र शुक्रलोते भागे पुमान्, रक्तोत्तेऽङ्गना। अनेनैव च कल्सेन यमकेष्वपि विनिर्दिशेत् ॥ (भे० सं० शा० ३/१०)

३. यथास्वमीति यदा शुक्रमाधिक्येन वर्तमानं बीजेन बहुधा भिद्यते तदा पुगमनिकत्वं, यदा तु रज्ज्वा आधिक्येन वर्तमानं वायुना बहुधा भिद्यते तदा स्त्रीगमनिकत्वं, इति बह्वर्थात्ता भवति ॥ (अ० ह० शा० १/६ की अरुण० टी०)

male child will be born and from later the female; if the division is such that both the parts have predominance of *śukra* then both the children would be male, similarly if both the portions have relatively more *āraṇya* then females will be born, similar views have been expressed by Bhela and Arupadatta.

In one of the edition of S.S. an additional verse for this subject is quoted, in which it is mentioned that during coitus, if male has excess and pure *retas*, then the pregnant woman will deliver two male children, however, if female has excess *śukra* then two females would be born. There is no doubt in it.

(४) युग्म में एक गर्भ के पुष्ट एवं एक के दुर्बल होने का कारण (Why one child in a twin is healthier than the other?)

कर्मात्मकत्वादिभ्रमांशभेदाच्छुक्रासुर्जीविन्द्रियैः कुक्षौ ।
एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमोऽप्यधिको विशेषः ॥ (च० सं० शा० २/१६)

कर्म के वशीभूत (वायु के) होने के कारण शुक्रांतर्व के विभाजन में (एक अंश अधिक एवं दूसरा अंश छोटा) भेद होने से जब कुक्षि में गर्भ की वृद्धि होती है तो एक यमल विशेष रूप से पुष्ट एवं दूसरा न्यून या छोटा होता है अर्थात् वायु द्वारा विभाजित बड़े अंश से उत्पन्न गर्भ बड़ा एवं छोटे अंश से उत्पन्न गर्भ छोटा होता है ।

The *wayu* directed by *karma* (deeds) when divides the *zygote* in such a way that one part is bigger than the other, then the child born from the bigger portion will be healthier and from the smaller portion comparatively weaker one.

गर्भाङ्ग विकृति (Teratologic abnormalities)

(अ) गर्भाङ्ग विकृति के सामान्य कारण (Causes of teratologic abnormalities)

बीजात्मकगर्भायकालादौर्धर्मातुल्यशब्दाद्विहरादौर्धः ।

कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः संस्थानवर्णैश्चयैकैतानि ॥ २९॥

वर्षासु काष्ठारमभनान्बुवेगारस्तोः सतिस्त्रोतसि संस्थितस्य ॥

यथैव कुर्तुर्विकृति तथैव गर्भस्य कुक्षौ नियतस्य दोषाः ॥ (च० सं० शा० २/२९, ३०)

यच्चोक्तं-यदि च मनुष्यो मनुष्यप्रभवः, कस्मात्त जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशरूपाः भवन्तीति; तत्रोच्यते-यस्य यस्य हृद्भावावयवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो भवति, तस्य तस्याङ्गावयवस्य विकृतिरपजायते, नोपजायते चानुपजायते; तस्मादभ्युपगतिरित्यत्र । सर्वस्य चात्मजनीन्द्रियाणि, तेषां भावाभावहेतुर्देव तस्मान्नैकान्ततो जडादिभ्यो जाता पितृसदृशरूपा भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ३/१७)

यदा शिवया दोषप्रकोपणोक्तान्यासेवमानया दोषाः प्रकुपिताः शरीरमुत्पन्नः शोणितगर्भांशवानुपपद्यते, न च कालन्त्येन शोणितगर्भांशवो दूषयन्ति, तदैव गर्भं लभते स्त्री; तदा तस्य गर्भस्य मातृजानामवयवानामन्यतमोऽवयवो विकृतिमापद्यते एकोऽंशवाऽनेके, यस्य यस्य ह्रवयस्य बीजे बीजभागे वा दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, तं तमवयवं विकृतिराविशति ॥ (च० सं० शा० ४/३०)

सर्पदृष्टिककृष्णपण्डविकृताकृतयश्च ये । गर्भास्त्वेते त्रिज्याश्च त्रैयाः पापकृता भूशम् ॥
गर्भो वातप्रकोपेण दौर्हदे वाऽजमानिति । भवेत् कुब्जः कुणिः पद्भुर्भूको मिन्मिण एव च ॥
मालतिप्रोस्तु नास्तिक्वादशुभैश्च पुराकृतैः । वातादीनां प्रकोपेण गर्भो वैकृतमानुयात् ॥

(सु० सं० शा० २/५०-५२)

अङ्गं प्रत्यङ्गनिवृत्तिः स्वभावादेव जायते । अङ्गप्रत्यङ्गनिवृत्तौ ये भवन्ति गुणागुणाः ।
ते ते गर्भस्य विज्ञेया धर्माधर्मनिमित्तजाः ॥ (सु० सं० शा० ३/३६)

विकृते विद्येन्याकृतीनाम् ॥ (अ० सं० शा० २/७)

यदा तु त्रिज्याः शोणितगर्भांशवो दोषाः क्रिच्छित् प्रदूषयन्ति तदा यो गर्भो भवति तस्य गर्भस्य यस्य मातृजान्यावयवस्य बीजे बीजभागे वा दोषः प्रकोपमापद्यते तं तमवयवं विकृतिराविशति ॥ ४७॥

यस्य हृद्भावावयवस्य बीजे बीजभागे वा उत्पत्तिर्भवति तस्य तस्याङ्गावयवस्य विकृतिरपजायते नोप-
जायतेऽनुपजायते ॥ ५३॥ (अ० सं० शा० २/४७ व ५३)

विशेषविकृताकारा जायन्ते विकृतैर्मलैः ॥ (अ० सं० शा० १/६)

बीज (शुक्र, शोणित) के दोष, आत्मकर्म (पूर्वजन्म के अशुभ कर्म)-दोष, आश्रय (गर्भाश्रय)-दोष, काल-दोष एवं माता के आहार-विहार-दोष आदि कारणों से प्रकुपित हुए दोष (वातादि) गर्भ में विभिन्न प्रकार के संस्थान, वर्ण एवं इंद्रियों के विकार उत्पन्न कर देते हैं । जिस प्रकार वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ वृक्ष काष्ठ, पत्थणखण्ड एवं अन्य के वेग के कारण (इन चीजों से टकराने के कारण) विकृत हो जाता है, उसी प्रकार कुक्षि-स्थित विकृत-दोष गर्भ में विभिन्न प्रकार की विकृतिर्या उत्पन्न कर देते हैं । शुक्र-दोष, प्रकुपित वायु^१ एवं शुक्रस्य प्रकुपित वायु^२ के द्वारा विकृत-सन्तान की उत्पत्ति का वर्णन अन्यत्र भी महर्षि चरक ने किया है ।

अन्यत्र महर्षि चरक ने मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति के बाद भी जडादि पिता से उसी भाँति के पुत्र की अनुत्पत्ति के कारणत्वा का स्पष्टीकरण करते हुए गर्भाण-विकारों के कारणों के बारे में लिखा है, कि बीज-स्थित जो बीजभाग दूषित होता है उस उस अंगावयव की विकृति होती है, बिना दोष के कोई विकृति नहीं होती, इस प्रकार दोनों ही बातें युक्तिसंगत हैं; अर्थात् यदि कुष्ठो पिता का त्वचोत्पादक बीजांश दुष्ट नहीं है, तो उत्पन्न बालक कुष्ठ-पीडित नहीं होगा, परन्तु यदि अतिवृद्ध कुष्ठ से उसका त्वचोत्पादक बीजांश दुष्ट है तो उत्पन्न बालक कुष्ठ से पीडित होगा^३ । समी इंद्रियाँ आत्मज हैं, इनका होना या न होना दैव के आधीन है, अतः जड़ या अन्ये आदि पिता से उत्पन्न बालक निश्चित रूप से पिता-सदृश नहीं होता, अर्थात् यदि अन्ये व्यक्ति के बीज में दृष्टि-उपधातक अशुभभाव विद्यमान है तो काकालीय न्याय से बालक अंधा होगा अन्यथा नहीं^४ ।

पुनश्च मातृज अंगावयवों में गर्भाणी के आहार-विहार का प्रभाव वर्णित करते हुए लिखा है कि जब वातादि दोषों के प्रकोपक आहारों का सेवन करने से स्त्री के शरीर के वातादि दोष प्रकुपित होकर शरीर में फैलते हुए शोणित (स्त्री-

१. शुक्रस्य दोषात्। रोगि का क्लीबमन्यायुर्विरूपं वा प्रजायते । (च० सं० सू० २८/१८)

२. (वायु)। कुपितस्तु खलु शरीरे। किं हि तं गर्भं विकृतिमापद्यत्यतिकालं वा धारयति। (च० सं० सू० १२/८)

३. शिषं मुखति बन्धाति शुक्रं गर्भमपि वा । विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्यः कुपितोऽनितः ॥ (च० सं० वि० २८/३४)

४. बीज इति शुक्रशोणिते। मनुष्यबीजं हि प्रत्यङ्गबीजभागसमुदायान्मकं स्वसदृशप्रत्यङ्गसमुदायरूपभूषणकम्। तेन पितृ यदि कुष्ठजापि भवति, बीजं चादुर्गं भवति कुष्ठवातात्वादि जनकं, ततो निष्कुष्ठान्येव त्पणादीन्यानुगतत्वादिबीजात् सदृशानि जायन्ते; यदा त्वतिवृद्धकुष्ठया पित्रोर्बीजमपि कुष्ठजनकदोषेण दुष्टं भवति, तदा दुष्टत्वादिबीजभागात् कुष्ठदुष्टैव त्पण् जायते ॥ (च० सं० शा० ३/१७ की चक्र टी०)

५. आत्मजानीति आत्मप्रतिबद्धकर्मजाति । भावाभावहेतुर्देवमिति इंद्रियभावे इंद्रियजनकं शुभम्, इंद्रियाभावे चाशुभं दैवं हेतुतिथयः । अन्धत्वादिबिन्दुरोषावरूपे दुर्दैवव कारणः तेन यदाऽन्येऽन्ये दृश्युपधातकमशुभं भवति, तदा काकालीयन्यायदन्धजालोऽप्यन्यो दूषयते । (च० सं० शा० ३/१७ की चक्र टी०)

बीज) एवं गर्भाशय को प्राप्त करते हैं, परन्तु सम्पूर्ण शोणित एवं गर्भाशय को दूषित नहीं करते (क्योंकि सम्पूर्ण रूप में दूषित होने से गर्भाधान हो नहीं होगा); तब स्त्री जो गर्भ धारण करती है, उस गर्भ के मातृज अवयवों या अन्य अवयवों में से एक या अनेक अवयवों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, बीज-स्थित विग्रह जिस अवयव के बीज-भाग में प्रकुपित दोष पहुँचते हैं, या प्रकुपित दोष जिस जिस अंगवयव के बीजांश को दूषित करतें हैं, उस उस अवयव में विकृति उत्पन्न होती है। टीकाकार चक्रपाणि ने अपने अपने हेतुओं से दूषित दोषों के साथ ही अनुबन्ध रूप में दूषित दोषों को भी कारण-स्वरूप माना है^१।

महर्षि चरक ने गर्भिणी की मानसिक अवस्था का प्रभाव भी गर्भाण-विकृति का कारण माना है उनके अनुसार गर्भोत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस जन्तु या प्राणी की ओर चला जाता है उसी उद्योग प्रकार के पुत्र को जन्म देती है^२।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि जो सर्प, वृश्चिक एवं कृष्णाण्ड आदि विषुक्त आकार वाले विषों के गर्भ होते हैं, उन्हें पाप कर्म के कारण जानना चाहिए। वात के प्रकोप से अथवा दौहद के अनुमान (पूरा न करने) से गर्भ कुबड़ा, कुपि (विकृति दृश्य का^३) पृथु, मूक अथवा भिन्नमिन् होता है। माता-पिता की नास्तिकता से, पूर्वजन्म के अशुभ कर्मों से और वायु आदि दोषों के प्रकोप से गर्भ विकृति को प्राप्त होता है पुनश्च दौहद-अवमान-जन्म विकृतियों का वर्णन करते हुए खड्ग, जड़, वामन, विकृताक्ष एवं अनक्ष (आँख-रहित) आदि का समावेश करते हुए स्पष्ट किया है कि दौहद-काल में जिन विन इन्द्रियों के अर्थ (इच्छा) की अवमानना होगी, गर्भस्थ विषु को उन उन इन्द्रियों में विकृति उत्पन्न होगी^४।

पुनश्च धर्म की प्रधानता वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भ के सभी अंग-प्रत्यंगों की निवृत्ति स्वभाव से ही होती है; अंग-प्रत्यंग की उत्पत्ति में जो गुण (सामान्यताएँ) एवं अवगुण (विकार) होते हैं वे धर्म एवं अधर्म के कारण स्वरूप होते हैं अथवा सामान्यताएँ धर्म के एवं विकृतियाँ अधर्म के कारण होती हैं।

प्रसव के समय अकाल-प्रवाहण से भी बर्धिर, मूक, कुब्ज एवं विकट सन्तान की उत्पत्ति हो सकती है^५।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि वायु के विकृत होने पर विकृत योनि या अकृति वाली संतान होती है। टीकाकार इन्द्र ने वायु के साथ ही अन्य दोषों को भी कारणस्वरूप माना है^६। इसके पूर्व लेखक ने षोडश वर्ष से कम आयु की स्त्री में, या ऋतुकाल के प्रारम्भ के तीन दिनों में गर्भाधान होने पर अथवा शुक्रातव को विकृति से विकृत गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन किया है^७।

पुनश्च चरक सदृश ही लिखा है कि यदि स्त्री के शरीर-स्थित प्रकुपित दोष शोणित एवं गर्भाशय को किञ्चित् दूषित करते हैं तो जो गर्भ उत्पन्न होता है उस गर्भ के जिस जिस मातृज अवयव के (बीज के) बीजांश में विकृति होती है,

१. दोषाणां स्महेतुसेवया बलवन्तं प्रकोपं दर्शयितुं, परहेतुसेवयाऽपि हि स्तोकमायया अनुबन्धरूपदोषप्रकोपो भवति; यथा-अस्तेन पितं जन्मान्नं श्लेष्मानुतं जन्त्यते ॥ (च० सं० शा० ४/३० की चक्र० टी०)
२. च० सं० शा० २/२५ (पृष्ठ १०२)
३. कुपिः विकलपाणिः (विकृतपाणिः-पातभेद)। (सु० शा० २/५१ की डल्ह० टी०)
४. सु० सं० शा० ३/१८-२१ (दौहद-पूर्ति-अपूर्ति परिणाम के अन्तर्गत उद्धृत)
५. सु० सं० शा० १०/९ (प्रसव के लिए प्रवाहण आदि के अन्तर्गत उद्धृत)
६. यदा त्वनितो वायो वा दोषः शुक्रातव केनचित् प्रकारेति तदा विकृतयोनीनां च गर्भाणां संभवः विकृतयोगो ये योधितः पुंसां संसृष्टयाः मृगामेधमजानादयो जायन्ते ते विकृताकृतयः काणपङ्कवाद्यः ॥ (अ० सं० शा० २/० की इन्द्र टी०)
७. ऊनपञ्चविंशति ऊनषोडशवर्षया विकलैन्द्रियो वा ऋतावधे च ऽपित्रये तथा दुष्टे शुक्रातवे इति ॥
अ० सं० शा० १/५ (पृष्ठ ७० एवं ८२)

गर्भ के उस उस अवयव में विकृति उत्पन्न होती है। जिस जिस अंगवयव उत्पन्न होकर बीज के बीजांश में विकृति होती है उस उस अंगवयव की विकृति होती है। बिना बीजांश के दोष के विकृति नहीं होती अर्थात् सामान्य बालक का जन्म होता है। सुश्रुत सदृश ही अकाल-प्रवाहण से कुब्जता होने का उल्लेख किया है^१।

अष्टाङ्गहृदयकार ने संक्षेप में ही लिखा है कि विकृत योनि या आकार के गर्भ वातादि दोषों के विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने दृष्ट दोषों का उन्मार्ग-गमन गर्भाङ्ग-विकृति का कारण माना है^२।

वाग्भट-द्वय ने भी शुक्रस्थ वायु-जन्म-विकारों के अन्तर्गत गर्भाङ्ग-विकृति होने का उल्लेख किया है^३।

महर्षि भेल ने बन्धत्व एवं विकृत गर्भ के कारणों का एक साथ उल्लेख करते हुए माता-पिता के बीज दोष, पच्य-रस का सेवन न करना, वेग-धारण एवं योनि-दोष आदि कारण माने हैं^४; अतः सम्पर्क रस वाले आहार का ऋतुकाल में सेवन का विधान बताया है। विशेषकर ऋतुकाल में सम्पर्क रस के न सेवन से विकृत गर्भ की उत्पत्ति का उल्लेख किया है^५। उदात्त रोग से पीडित, अहित सेवी दम्पती से बलहीन एवं अन्ये आदि सन्तान की उत्पत्ति^६; तथा हाथी एवं कुत्ते आदि के स्वरूप की सन्तानोत्पत्ति का कारण वायु तथा आकाश की विकृति एवं दैव-प्रकोप माना है^७।

आचार्य भवमिश्र ने दृष्ट शुक्र की प्रजोत्पन्न असमर्थता के सुश्रुत के वर्णन के स्पष्टीकरण में लिखा है, कि विकृत शुक्र जन्माश्रय आदि की उत्पत्ति का कारण होता है। अन्यत्र उन्होंने महर्षि सुश्रुत का ही अनुमान किया है^८।

योरालाकार पुस्तक में पापकर्म को ही कारणभूत माना गया है^९।

Due to the abnormalities of *ovum* (ovum and sperms), *atma-karma* (deeds of previous life), *āśya* (uterus), *kāla* (time factor or abnormality of *rukāla*) and dietetics along with mode of life of mother, the vitiated *dozas* produce abnormalities of fetus, affecting its appearance, complexion and *indriyas*. As a tree fallen in stream of water of a river gets disfigured due to effect of (being knocked by) woods, stones and current of flowing water, similarly the *abgūravated dozas* situated in *kukūsi* (uterus) disfigure the fetus.

१. अ० सं० शा० ३/३० (प्रसव के लिए प्रवाहण आदि में उद्धृत)
२. विकृतैर्नरैः। वातादिभिर्दुष्टैर्नृणां गमिभिः। (अ० ह० शा० १/६ की अरण० टी०)
३. शुक्रस्य शोषमुत्सर्गं सङ्गं विकृतिमेव वा। तद्वदर्थस्य शुक्रस्थः-। (अ० सं० नि० १५/१५, १६; अ० ह० नि० १५/२३)
४. बीजदोषाद्याय सस्यं न सम्यक्प्ररोहणी (ति)। माता पित्रोस्तु दोषेण तथा गर्भः प्रय (ति) च्छति ॥ तस्मात् सम्यग्रसाहस्यदुक्कलेऽथ दम्पती। रहस्सयोगेयतां स्मरन्ती मनसा विभुः। विकृताः स्तुरार्था वै रसाप्यनिषेवणीः। सन्ध्याणप्रात वेगानां योनिदोषेण वा पुनः ॥ (शे० सं० शा० ३/२, ३, ४)
५. इह खलु त्रिषु दशरोगेषु पुमान् रसेन संतुष्यते। आसां तु खलु चतसृणां योनीनामुक्कले यदा रसास्सम्यग् व्याप्ति वा गच्छति तदा गर्भस्तिष्ठे (ष्ट) त्यविकृतः विपश्ये विपाययः ॥ (शे० सं० शा० ५/४)
६. शे० सं० सू० १२/१५ व १६ (पृष्ठ ८७)
७. इमं धर्मासंसारं प्रयोगादि भवेच्छुचि ॥ १५ ॥ वाय्वाकाशदुर्गुको हि दैवतोचितेषु तु। अन्तर्जातो जातवेदः प्रभवयोपकल्पते ॥ (शे० सं० शा० ३/१५, १६)
८. 'यन्तु - 'वातादि दुष्टेतसः प्रजोत्पत्तेर न समर्थाः'। इति सुश्रुतः। तत्र शुद्धप्रजोत्पत्तेर न समर्था इति बोद्धव्यम्। योगदिनाऽशुद्धास्तु प्रजा वातादिदुष्टशुक्रा अपि जनयन्ति जन्माश्रयधरपङ्कवादि सम्भावत् ॥ २७ ॥ सर्वशिक्षकृष्णान्धजन्तयो विकृताश्च ये। गर्भस्ते योधितलाश्च योगाः पापकृतौ भूयन् ॥ ६० ॥ गर्भो वातप्रकोपेण दोहरे चापमानिते। भवेत् कुब्जः कुपिः भङ्गुर्भूको मिमिन एव च ॥ ६१ ॥ (पा० प्र० पूर्व ३)
९. सर्वशिक्षकृष्णान्धविकृताकृतयश्च ये। गर्भाश्चिन्ति त्र्यश्वैव योगा पापकृता भूयन् ॥ (यो० ८० गर्भ० टी० नि०)

Abnormalities of *śukra* and *vāyu*, as well as vitiated *vāyu* located in *śukra* are also said to produce congenital anomalies.

Caraka has explained further that teratologic abnormalities depend upon the condition of *bija*, not on the physical status of couple, or in other words what-so-ever part of *bija* is defective, the body part developing from that portion of *bija* will be abnormal. Any organic abnormality can not occur without abnormality of corresponding portion of *bija*. Thus if the portion of *bija* of a *kuṣṭhī* (leptous) man responsible for formation of skin is defective then only the born child will have *kuṣṭha*, however, if that part is not abnormal then the child will be healthy. All the *indriyas* are derived from *ātmā*, thus their presence, absence or abnormalities depend upon the fate. An idiot or blind father does not always produce idiot or blind child, however, if the *bija* of a blind man possesses the abnormal factor for damaging eye-sight, then the born child would be blind by *kāṇḍālyā nyāya*, otherwise not. Similar hypothesis has also been expounded later, that due to abnormalities in dietetics etc. of woman, if her entire *bija* becomes abnormal then she will not conceive, however, if a small portion is defective then the born child will have the abnormality of corresponding body part of maternal origin. Psychology of the woman also affects the fetus i. e. at the time of impregnation, to what-so-ever type of animal the woman thinks, the child will have similarity with that.

Sūśruta says that the fetus having shape of snake, scorpion or field-pumpkin etc. are the results of sins or bad deeds. Due to vitiation of *vāyu* and insult or nonfulfilment of *dohyā* (desires of pregnant mother) the fetus may become humpbacked, main or crooked armed, lame, dumb and nasal voiced. Dilating the same he writes further that this nonfulfilment of *dauhyā* results in birth of crooked-legged, idiot, dwarf, dishaped-eyed or absent-eyed child, objects/desires of what-so-ever *indriya* are neglected/ not provided, the fetus develops abnormality of the same. Thus in short atheism of parents, bad deeds of previous life (of the fetus) and aggravation of *vāyu* are three causes of teratologic abnormalities. Development of body parts is a natural phenomena, the qualities and normalcy in body parts are the results of righteousness and the abnormalities of unrighteousness. Bearing-down efforts made by the woman in absence of labour pains are also said to produce deaf, dumb, hump-backed child or the one with abnormally located body-parts.

Vāgbhaṭa I and II say that the cause of teratologic abnormalities is vitiation of *vāyu* and also due to *vāyu* located in *śukra*. Indu opines that other *doṣas* also cause fetal abnormalities, while Arunadatta says that upward movement of *doṣas* is a causative factor. Vāgbhaṭa I has enumerated the causes as impregnation of a woman of less than sixteen years of age, conception during first three days of menstrual flow, abnormality in *śukra* and *āraṇya* and also delivery of hump-backed child due to bearing-down efforts made in absence of labour pains. He has also described the abnormality of a part of *bija* etc. as described by Caraka.

Bhela has enumerated *bija-dōṣa* of mother and father, absence of use of beneficial (*pathya*) *rasas*, suppression of natural urges and *yoni-dōṣa* (gynecological abnormalities) as causative factors for both infertility and teratologic abnormalities. The woman not using

proper *rasas* during *ṛitukāla* delivers abnormal child. The couple suffering from *udāvara*, consuming injurious diet give birth to a weak and blind child. The vitiation of *vāyu* and *ākāṣa* and also curses of god result in birth of a child having abnormal shape like an elephant or dog etc.

Bhāvanīśra emphasizing the abnormality of *śukra* as a cause of congenital blindness etc. has corroborated the views of Sūśruta.

Yogarāṭnākara has described only unrighteousness as a cause.

विमर्श (Comments)

पूर्ववर्णित विषय को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आचार्यों ने वात-विकार एवं पूर्वजन्म-कर्म या पापकर्म का गर्भाङ्ग-विकृति के कारण-स्वरूप प्राधान्य माना है, परन्तु चरक एवं चापट-वर्णित बीजांश-दोष की कल्पना सराहनीय है जो किसी सीमा तक आधुनिक ग्रन्थों में वर्णित क्रोमोसोमल या जिनोटिक विकृतियों से सामञ्जस्य रखती है।

Preceding description clearly shows that vitiation of *vāyu*, deeds of previous life, unrighteousness are basic etiological factors described for teratologic abnormalities. The concept of vitiation of a portion of *bija* reflects to chromosomal or genetic abnormalities. (आ) गर्भोपघातकर भावों या दौहद काल में प्रयुक्त द्रव्य-जन्य विकार (Abnormalities developing due to *garbhopaghātākara bhāvas* or *articles used during dauhyāda*)

महर्षि चरक ने गर्भोपघातकर भावों के अन्तर्गत एवं महर्षि सुश्रुत ने दौहद-काल में विभिन्न द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न कतिपय जन्मजात विकारों का उल्लेख किया है जिनका यथास्थान अग्रिम अध्याय में वर्णन किया जायेगा।

Congenital abnormalities due to use of diet or mode of life described under *garbhopaghātākara bhāvas* or during *dohyāda* by Caraka and Sūśruta respectively have been discussed in next chapter.

(इ) माता के विभिन्न दोष-प्रकोपक आहार का प्रभाव (Effect of different *doṣa-vitiating diet of mother upon the fetus*)

(१) वातल आहार-जन्य गर्भ-विकृतियाँ (Abnormalities due to *vāta-vitiating diet*)

यदा च लब्धगर्भाऽन्वक्ष्यसेव वातलान्यासेवते तदाऽस्या वायुः प्रकुपितः शरीरमनुसर्पन् गर्भाशयेऽवतिष्ठमानो गर्भस्य जडबधिरमूर्कमिम्पणगदगुञ्जकुञ्जवानमहीनाङ्गारिकाङ्गुलान्यन्म वा वातविकार करोति॥

(अ० सं० शा० २/१४)

वातलैश्च भवेद्गर्भः कुञ्जान्वजडवानमः॥ (अ० ह० शा० १/४८)

जब स्त्री गर्भवती हो जाने के बाद भी निरन्तर वातल आहार (या अन्य वस्तुओं) का सेवन करती है, तो उस स्त्री का प्रकुपित हुआ वायु शरीर में विचरण करता हुआ, गर्भाशय में स्थिर होकर, गर्भ को जड़, बधिर, मूर्क, मिम्पिन या गदगद आवाज वाला, गुञ्ज (लंगड़ा), कुञ्ज, वानम (छोटे शरीर वाला), हीन या अधिक अंग वाला या अन्य वात-विकारों से युक्त कर देता है।

अष्टाङ्गहृदय के मतानुसार वातल आहार के अत्यधिक सेवन से गर्भ कुञ्ज, जड़ एवं टिपना हो जाता है। चापट-द्रव्य ने अन्वत्त लिखा है कि गर्भावस्था में वायु की विकृति के कारण कान की शकुलित (बाह्यकर्ण) सङ्कुचित

हो जाते हैं। इस विकार का नाम कृचिकर्षक है^१।

भेल ने लिखा है कि स्त्री या पुरुष दोनों ही यदि ऋतुकाल में रक्ष आदि जलल आहार का सेवन एवं वेग-विधारण करते हैं, तो प्रकृति वात से गर्भ के शोणितदि दूषित होकर गदाद, वायिभ्रं, मिमिणादि अन्य वातज व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं^२।

When a pregnant woman consumes continuously the diet capable of aggravating *vāta*, then vitiated *vāyu* moving through whole body reaches uterus, settles there and makes the fetus (child) *jaḍa* (idiot), deaf, dumb, having hoarse or nasal voice, lame, humpbacked, dwarf, possessing less or more number of body parts and other abnormalities arising due to *vāyu*. At another place Vāgbhāṭas have mentioned that due to abnormality of *vāyu* of fetus, the pinna of ear contracts, this is known as *kūcikarṣaka*.

Bhela says that if the couple consumes *rūkṣa* (dry) etc. *vāta* vitiating diet during *rūkṣitā* and suppresses natural urges, then aggravated *vāyu* vitiates *rakta* etc. (*dhiātus*) of the fetus and produces hoarse or nasal voice, deafness and other disorders of *vāta*.

(२) पित्तल आहार-जन्य गर्भ-विकृतिर्याँ (*Abnormalities due to pitta-vitiating diet*)

तथा वायुवित्तमपि खलितपित्तमश्रुहीनतात्त्वद्वन्द्वकेशपङ्क्त्यादीनि॥ (अ० सं० शा० २/५५)

पित्तलैः खलितैः पिङ्गैः,..... ॥ (अ० सं० शा० १/४८)

वायु के सदृश पित्त भी (पित्तल आहारादि के सेवन से प्रकृति होकर शरीर में परिभ्रमण करता हुआ गर्भाशय में स्थिर हो गर्भ में) खलित, पतित, रमश्रुहीनता, त्वचा, नख एवं केशों में पित्तल वर्णता आदि अन्य पित्तल विकार^३ उत्पन्न कर देता है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी खलित एवं पैन्य को शैतिक विकार माना है।

महर्षि भेल ने लिखा है कि माता-पिता के द्वारा ऋतुकाल में पित्त-प्रकोपक आहारादि के सेवन से पित्त प्रकृति होकर गर्भ को दूषित करता है^४।

Like *vāta* the vitiated *pitta* produces baldness, premature greying of hair, absence of hair on face, tawny colour of skin, nail and hair etc. and other abnormalities of *pitta*. Bhela says that aggravated *pitta* produces its specific abnormalities.

(३) रलेष्मल आहार से उत्पन्न गर्भाङ्ग-विकृतिर्याँ (*Abnormalities due to kapha-vitiating diet*)

रलेष्मा तु कुष्ठकिलाससदन्तत्वादीनि ॥ (अ० सं० शा० २/५६)

१. गर्भोत्पित्तल संकुचिता शकुली कृचिकर्षकः ॥ (अ० सं० शा० २/१५ एवं अ० सं० १/७/१६)

२. (अ) अर्ध स्त्रीपुरुषवदुता(का)दे(ले) रूक्षाणि वातरा(ला)न्म्रपान्मनि सेवेते वेगश्च धारतः, तयोर्मभः शोणितदिषु वातसन्निधौ विसृतो भवति; गद्वद्वाधिर्यमिन्मिण्यन्मभ्यो च वातपित्तविकाराणामन्यतमं प्राप्नोति । एवमेव पित्तलेष्मलानुशुक्तले माता पित्रोस्सेवमानयोः पित्तलेष्मादुषितो गर्भः संभवति ॥ (अ० सं० शा० ५/११)
(आ) यद्यपि संहिता में 'वातपित्त' विकार वर्णित है परन्तु गदाद आदि सभी उल्लिखित व्याधियाँ वातज ही हैं एवं प्रारम्भ में केवल वात के दूषित होने तथा पित्त-विकारों का पृथक् निर्देश होने से 'वातपित्तविकाराणां' के स्थान में 'वातजन्यविकाराणां' पाठ अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है।

३. आदि ग्रहणेन पित्तविकाराणां ग्रहणं ॥ (अ० सं० शा० २/५५ की इट्ट टी०)

४. वातान्तात्त वल्लिखत ।

..... शिशो पाण्डुः कफान्मभिः ॥ (अ० सं० शा० १/४८)

रलेष्मा से (वायु, पित्त सदृश आहारादि से कुचिप्त होने पर) कुष्ठ, किलास एवं सदन्त-जन्म आदि अन्य रलेष्मा के विकार होते हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने शिश एवं पाण्डु को कफज विकार माना है।

महर्षि भेल ने लिखा है कि माता-पिता के द्वारा ऋतुकाल में रलेष्म-प्रकोपक आहारादि के सेवन से कफ प्रकृति होकर गर्भ को दूषित करता है^१।

Vitiated *kapha* produces *kushpa* (leprosy), *kiāsa* (a type of skin disorder) and congenital presence of teeth. Vāgbhāṭa II has mentioned that *świtra* (leucoderma) and *pāṇḍu* (anemia) arise due to consumption of diet capable of vitiating *kapha*. Bhela says that aggravated *kapha* produces its specific abnormalities.

(४) त्रिदोषज आहार से उत्पन्न गर्भाङ्ग-विकृतिर्याँ (*Abnormalities due to diet vitiating all the dosas*)

त्रिवर्गो मिश्रान् विकारान् । (अ० सं० शा० २/५६)

त्रिदोषज आहारादि के सेवन से मिश्र विकार होते हैं।

Due to consumption of diet capable of vitiating all the three *dosas* the aggravated *tridosas* produce abnormalities described under all the three *dosas*.

(ई) अन्य (*Others*)

महर्षि हारीत ने यद्यपि माता के द्वारा विशिष्ट आहार-विहार के सेवन का वर्णन तो नहीं किया, परन्तु वात से वात प्रकृति, पित्त से पित्तज प्रकृति तथा रलेष्मा से स्निग्ध, रयाम, लोमश शरीर से युक्त, शिर के बड़े या घने बालों वाले, रसूल एवं दोषप्रकृति सन्तान, पुनश्च पित्त से रक्ष तथा कफरक्त से स्निग्ध सन्तान होने का वर्णन दिया है^२। यद्यपि प्रकृति का निमण शुक्रार्तव-स्थित दोषों से होता है पर आहार-रस-स्थित दोष भी सहायक हो सकते हैं।

वाग्भट-हृदय ने विशिष्ट कारण न बताते हुए लिखा है कि गर्भ में ही एक अथवा अनेक पिप्पली के समान वेदना-रहित मासाङ्गुर हो जाते हैं जिनको पिप्पली कहते हैं^३।

Hārīta has mentioned that from *vāta* develops *vāta prakṛti*, from *pitta* the *pitta prakṛti* and *rūkṣatā* (dryness), from *kapha* an unctuous and hairy body, long hair of scalp, heavy or fat constitution and *dūrgha prakṛti* and from *kapha* with *rakta* the child gets unctuousness. Various body complexions derived from these *dosas* are already described earlier.

Vāgbhāṭas, without giving any etiology write that in the fetus elongated, painless,

१. आदि ग्रहणेन रलेष्मविकाराणां ग्रहणम् ॥ (अ० सं० शा० २/५६ की इट्ट टी०)

२. भै० सं० शा० ५/११ (पृष्ठ १८२) ।

३. वाते रयामः पुंरुषो वातप्रकृतिसम्भवः । पित्तेन गौरो भवति पित्तप्रकृतिवान्म्वेत ॥ ३१॥

रलेष्मणा जायते स्निग्धः रयामश्च लोमशस्तथा । दीर्घशरीरोहः स्मूलो दीर्घप्रकृतिसंयुतः ॥ ३२॥

वातरक्तेन कुण्डोपि पित्तकेन पिङ्गलः । पित्तांश नरो रूक्षः स्निग्धः रयामः कफसृजना ॥ ३३॥

(हो० सं० षष्ठस्थान १/३१, ३२, ३३)

४. एको गौरुर्नकेवला गर्भे मासाङ्गुरः स्थिरः । पिप्पली पिप्पलीमनः ॥

(अ० सं० शा० २/११/६ एवं अ० सं० १/७/१६, १७)

muscular sprouts develop which are termed *pipral*.

विमर्श (Comments)

आचार्यों ने बात विकारों के अन्तर्गत अधिकांश वे ही विकार परिणीत किए हैं जो कि जन्मजात हो सकते हैं, जब कि पित्त के अन्तर्गत शरीर में बाद में होने वाले विकारों यथा खलित, पतित, शमश्रुहीनता आदि का उल्लेख तथा कफज विकारों में कुष्ठ, किलस, धिग आदि का उल्लेख किया है, जिसका कि स्पष्ट अर्थ है कि इन विकारों की उत्पत्ति में गर्भावस्थावस्था दौकिक स्थिति प्रभाव डालती है या अन्य शब्दों में इन व्यथियों को जिनेटिक माना जा सकता है। पित्तज-विकारों के अन्तर्गत वर्णित पित्रल-वर्णता नवजात-शिशु कामला की द्योतक हो सकती है।

Under the heading of *vāta* only congenital disorders have been described, however under *pitā* and *kapha* all the entities described are evident only in later life, which indicates that environment during gestational period produces certain such conditions which act as a predisposing factor for the diseases or these diseases have genetic predisposition. Tawny colour of skin described under *pitā* could be the reference of jaundice neonatorum.

अस्थि-विरहित गर्भ की उत्पत्ति के कारण (Causes of birth of a boneless fetus)

यदा नार्यानुपेयातां वृषस्यन्यौ कथञ्चन। मुञ्चतः शुक्रमन्योऽन्यमनस्थिराव जायते ॥

ऋतुस्नाता तु या नारी स्वने भैशुनमावहेत्। आर्तव वायुरादाय कुक्षौ गर्भं करोति हि ॥

मासि मासि विवर्धेत गर्भिण्या गर्भलक्षणम्। कलत्तं जायते तस्या वज्रितं पैतृकैर्गुणैः ॥

(सु० सं० शा० २/४७ से ४९)

जब दो वृषस्यन्तौ (वृषभ की इच्छा करने वाली गौ अर्थात् पुरुष या काम की इच्छुक स्त्रियाँ या अत्यन्त कामातुर) स्त्रियाँ समागम करती हैं एवं किसी प्रकार एक दूसरे में शुक्र का उत्सर्ग करती हैं तो अस्थि विरहित या अल्प कोमलस्थि युक्त गर्भ की उत्पत्ति होती है।

यदि ऋतुस्नाता स्त्री स्वप्न में भैशुन करती है या अनुभव करती है, तो (विकृत) वायु आर्तव को कुक्षि (गर्भाशय) में ले जाकर गर्भ की उत्पत्ति कर देती है। उस गर्भिणी में गर्भ के लक्षण प्रतिमास (या मासानुमासिक क्रम से) बढ़ते जाते हैं तथा उसे पित्राण (केश, रसश्च, लोम, नख, दन्त, शिरा, स्नायु, धननी, रेत प्रभृति) से विरहित कलत्त की उत्पत्ति होती है। इन दोनों स्त्रियों का जेज्जदाचार्य ने पाठ नहीं किया।

भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर पुस्तकों में भी यही विचार व्यक्त किए गये हैं।

When two hypersexual women indulge in sexual act then they ejaculate *śukra* in each other. Thus conceived fetus is either boneless or has very soft bones.

When a woman having taken bath after her menstrual period (4th or 5th day of menstruation) dreams of coitus, the *vāyu* taking *ārtava* to the uterus makes the conception,

१. अनस्थिराति ईददर्थे नन्, तेनाल्पकोमलास्थिः ॥ (सु० सं० शा० २/४७ की इल्ल० टी०)

२. आर्तव ऋतुकात्तव शुद्ध शोणितम् पैतृकैर्गुणैरिति केशरसश्चलोमखन्तशिरास्नायुधननीतः प्रभृतिभिः। इमौ द्वौपि स्त्रीकौ जेज्जदाचार्यो न पाठितौ। (सु० सं० शा० २/४९ की इल्ल० टी०)

३. (अ) यदानार्या ॥ ५७ ॥

ऋतुस्नाता स्वने भैशुनमावहेत्। ॥ ५८ ॥

मासि मासि प्रवर्धेत स गर्भा गर्भलक्षणः। ॥ ५९ ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३; सुश्रुत सद्रूप ही)

(अ) ऋतुस्नाता पैतृकैर्गुणैः। (यो० २० स्त्रीगर्भो० सि०, सु० सद्रूप ही)

which increases every month and the pregnant woman has all the signs and symptoms of pregnancy. This *kalala* when delivered, is without the paternal body-parts (bones, hair, nail, etc.).

विमर्श (Comments)

आयुर्वेदीय सिद्धान्तों के अनुसार गर्भ शुक्र, आर्तव एवं जीव के ही संयोग से बनता है। स्त्री-शुक्र को पुरुष-शुक्र के समकक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि वह पुरुष के शुक्र के समान गर्भजनक नहीं है (स्त्री शुक्रान्तर्गत पृष्ठ ४९ से ५२ में वर्णित), अतः दो स्त्रियों के परस्पर संयोग से या ऋतुकात्त में स्वप्न-भैशुन से किसी प्रकार की गर्भोत्पत्ति मानना शास्त्रसंगत, युक्तिसंगत एवं प्रत्यक्ष-प्रमाण-युक्त नहीं है, सम्भवतः इसी कारण टीकाकार जैज्जदाचार्य इन स्त्रियों का पाठ ही नहीं करते (पूर्व वर्णित इल्ल० टी०)। यद्यपि इस प्रकार की गर्भोत्पत्ति का निश्चित स्मरीकरण कठिन है फिर भी वर्णन के निम्न सम्भाव्य कारण हो सकते हैं।

(१) स्त्रोक्त प्रक्षिप्त है, अतः आभा नहीं।

(२) उपर्युक्त वर्णन अति कामातुर या मानसिक रूप से विकृत स्त्रियों का वर्णन है। प्रजनन-क्रिया सम्बन्धी मानसिक विकृति अनार्तव का एक कारण है, अतः इन स्त्रियों में प्रारम्भ के अनार्तव एवं बाद के कुछ अधिक ग्रन्थित रक्तस्राव को देखकर उपर्युक्त वर्णन की कल्पना की गई।

(३) अनैतिक सम्बन्धों के कारण प्राप्त गर्भ का प्रारम्भिक दिनों में गर्भस्राव करवाने पर नवीन, अस्थिविरहित गर्भ निकलता है। सामाजिक भय के कारण स्त्रियों ने उपर्युक्त मानसिक विकृति का इतिवृत्त दिया एवं आचार्यों ने उसे सही मान लिया।

(४) विकृत गर्भोत्पत्ति का भय दिखकर स्त्री को अप्राकृतिक संभोग की प्रक्रिया से दूर रहने का निर्देश।

In *Āyurveda* classics it is clearly mentioned that conception is the result of union of *śukra*, *ārtava* and *jīva*. The *śukra* excreted by female is useless for conception, thus the occurrence of pregnancy without active participation of male partner is neither mentioned in classics, nor seen in practice, nor stands the test of logics. Probably due to this confusion Jejjibācārya has not quoted these verses. However, probable explanations can be given in following way:—

- 1) The verses are not authentic and have been added by some later worker.
- 2) The description is of women having perverted psychology or hypersexuality. In various psychological conditions specially related to reproductive system amenorrhoea is one of the common manifestation, probably amenorrhoea followed by menstruation having excessive clotted blood is the source of this description.
- 3) The women having got themselves criminally aborted for illegal pregnancy, specially during early stage of gestation and expelling the products of conception in pieces gave this misleading history, which was accepted by the authors.
- 4) The author's main aim was to deter the women from these abnormal sexual behaviours by infusing fear of abnormal fetus.

गर्भस्थ शिशु के अस्तन का कारण (Reasons for absence of fetal cry)

जरायुणा मुखेच्छन्ने कण्ठे च कफवेष्टिते। वयोमर्गानिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदति ॥

(सु० शा० २/५४; अ० सं० शा० २/६५ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/३२९)

वायु से मुख के आच्छादित होने, कण्ठ के कफ से आवेष्टित या अवरुद्ध होने तथा वायु के मार्ग का निरोध होने के कारण गर्भस्थ शिशु नहीं रोता। टीकाकार डल्लण ने म्पष्टिकरण में लिखा है कि घोष-जनक वायु के मार्ग का अवरोध होता है, क्योंकि निःश्वासादि रूप वायु का वर्णन किया जा चुका है इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर गर्भ जीवित ही नहीं रहेगा।

As the aperture of fetal mouth (*mukha*) is enveloped with *jaṛyū* (amniotic membrane), the throat is covered with *kapha* (mucus) and the passage of *vāyu* is obstructed, hence the fetus does not cry. Dāhana has explained that the passage of *ghṛṣa-janaka vāyu* (*vāyu* capable of producing sound) is obstructed, but not of normal one, as its functions of respiration etc. have already been described earlier and obstruction to its passage would lead to fetal death.

गर्भ में मल इत्यादि के अभाव का कारण (Reasons for absence of fetal excretas)

मलत्वत्वाद्योगाच्च वायोः पक्वाण्यस्य च। वातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति हि॥
(सु० सं० शा० २/५३)

अज्ञातस्य साक्षाद्वर्णनानुपवेशादमतत्वाच्च रसस्य गर्भस्थं स्थूलमालासम्भवः।
(अ० सं० शा० २/३४)

मल के अत्यल्प होने एवं पक्वाण्य में वायु के अयोग या ईश्वर योग होने के कारण गर्भस्थ शिशु वात (अपान वायु), मूत्र एवं पुरीष का त्याग नहीं करता।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि अनुसन्न या गर्भस्थ शिशु में अन्नपान आदि के साक्षात् रूप में प्रविष्ट न होने के कारण एवं आहार-रस के मल-रहित या प्रसाद रूप होने के कारण गर्भ में स्थूल मल का अभाव होता है।

महर्षि मेरु ने भी उदरस्थ शिशु के आहार न लेने के कारण पुरीष की अनुपस्थिति का वर्णन किया है।^४

आचार्य भावमिश्र ने वायु की अत्यन्त एवं उसका पक्वाण्य में अयोग होना ही वात, मूत्र एवं पुरीष के न होने का कारण माना है।^५

Suśruta says that since the excretas are very less in quantity and the *vāyu* is not in functioning state or has negligible functions in *pakvāṇya* (large bowel), thus the fetus does not pass flatus, feces or urine.

Vāgbhaṭa I opines that since in fetus, food and liquid do not enter directly (into their digestive system) and the *āhāra-rasa* is free from waste products or is essence of digestive food, thus there is no gross amount of feces in the fetus.

Bhela and Bhāvamśīra have also expressed almost similar opinion.

१. वायोर्मानसिरोधादिति घोषजनकस्य वायोर्मानसिरोधादित्यर्थः। निश्वासादिरूपस्य तु वायोर्निःसर्गामग्रे वक्ष्यति, यतस्तदभावे जीवितभावा एव भवति गर्भस्थ ॥ (सु० सं० शा० २/५४ को डल्ह० टी०)
२. वायोयोगात् इति नञ् ईषदर्थे, तेनेषायोगात्। (सु० सं० शा० २/५४ को डल्ह० टी०)
३. रसः सोऽमलः प्रसार रूपत्वादित्यर्थः ॥ (अ० सं० शा० २/३४ को इन्दु टी०)
४. अत्राह किन्तु (शु) गर्वा (मो) मातु (रस) रस्योऽजगति न वेति। अत्रोच्यते, नाजगति। ये (य) दि ह्यश्रीयात् स्वादस्या (स्य) पुरा (ते) प्रमातीतकालम्। न वेद (म) त्ति ॥ (पे० सं० शा० ४/३२)
५. वातत्वत्वाद्योगाच्च वायोः पक्वाण्यस्य च। वातमूत्रपुरीषाणि गर्भस्थो न विमुञ्चति ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३२८)

विमर्श (Comments)

यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में गर्भस्थ शिशु मल एवं अपान वायु का त्याग नहीं करता, परन्तु मूत्र का त्याग करता है अतः सुश्रुतेक मूत्र का अभाव युक्तिसंगत नहीं है। वाग्भट-वर्णित स्थूल मल से यदि ब्रह्मदान स्थित मल का ग्रहण किया जाय, तो उसकी भी अनुपस्थिति नहीं होती, यद्यपि सामान्यतया गर्भशयान्तर स्थिति में इसका विसर्जन नहीं होता परन्तु अवसाद की स्थिति होने पर गर्भ गर्भशयान्तर स्थिति में ही इसका त्याग कर देता है।

गर्भ अपनी गर्भशयान्तर स्थिति में कभी नहीं रोता, परन्तु विरले गर्भ का अप्पन्तर वर्तन करने अथवा सामान्य या अपाणस्य शिशु के प्रसव के समय उत्कल का विदार होने के बाद वातावरण की गर्भशयान्तर प्रविष्ट वायु के गर्भ के द्वारा बारम्बार निश्वास से अन्दर तथा उत्कल से बाहर निकालने पर एक विशिष्ट रोने सदृश आवाज आती है जिसे गर्भ-क्रन्दन (वॉजिटस यूटेरिनस) कहते हैं। इसका गर्भ पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता।^१

Though normally fetus does not pass flatus or feces, however, it does secrete urine, hence Suśruta's version of absence of micturition does not seem to be proper. If gross amount of feces described by Vāgbhaṭa is considered as feces of large bowel, then it is also not absent, though normally fetus does not pass it, yet in hypoxic state the fetus does pass it.

Fetus never cries, however rarely, during internal version or after rupture of amniotic membrane during normal or premature delivery, the atmospheric air entered in uterus is inhaled then exhaled by the fetus repeatedly producing typical sound called vagitus uterinus which does not have any untoward effect upon the fetus.

गर्भिणी की व्याधियों का गर्भ पर प्रभाव (Effect of mother's diseases upon the fetus)

दोषभिषयैर्गर्भिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते। स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥

(सु० सं० शा० ३/१७ एवं भा० प्र० पूर्व० ३/३३४)

दोषों से (दोषों की विकृति से) अथवा अभिघातादि से गर्भिणी स्त्री का जो जो भाग या अंग पीड़ित होता है, गर्भस्थ शिशु का भी वही अंग पीड़ित होता है।

What-so-ever part of the female's body is afflicted either by vitiation of *doṣas* or trauma, identical part of the fetal body also suffers from the same trouble.

विमर्श (Comments)

गर्भस्थ शिशु के माता के ऊपर पराक्रान्त होने का ही यह भी एक वर्णन है, क्योंकि क्रियात्मक क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि माता के पीड़ित होने पर भी शिशु स्वस्थ रह सकता है।

All the disorders of mother do not influence fetus in identical manner. The description might have been given to emphasize the dependence of fetus over the mother.

गर्भ के शुभ एवं अशुभ भाव (Auspicious or subha and inauspicious of aśubha features of fetus)

निमित्तमात्मा प्रकृतिर्वृद्धः कुक्षौ क्रमेण च। वृद्धिहेतुश्च गर्भस्य पञ्चार्थाः शुभसंज्ञिताः ॥ ४२ ॥

१. मुर्तारक की "ऑर्थोटिक् ऑब्स्टेट्रिक्स" पृष्ठ १४२

अजन्मनि न यो हेतुर्विनाशो विकृतावधि। इमां स्त्रीमशुभान् भवानाहुर्गर्भविधातकान् ॥ ४३॥
शुभशुभसमाख्यातान्ष्टौ भवानिमान् भिषका। सर्वथा वेद यः सर्वान् स राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ ४४॥
अवात्पुण्यायान् गर्भस्य स एवं ज्ञातुमर्हति।

ये च गर्भविधातोक्ता भावास्तांश्चायुदाहरीः ॥ ४५॥ (च० सं० शा० ४/४२ से ४५)
गर्भ के कारण, गर्भ की आत्मा, गर्भ की प्रकृति, गर्भ की कुक्षि में क्रमिक वृद्धि एवं गर्भ की वृद्धि के हेतु ये पाँच गर्भ के शुभ (अर्थात् पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठेय) भाव हैं; एवं गर्भ के उत्पन्न न होने के कारण, गर्भ विनाश के कारण एवं गर्भ-विकृति के कारण ये तीन गर्भ के अशुभ या गर्भ के घातक भाव कहे जाते हैं। इन आठ शुभ एवं अशुभ कहे जाने वाले भावों को जो वैद्य भलीभाँति जानता है वह राजा की विक्रित्ता करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए वैद्य गर्भ-प्राप्ति के उपायों को एवं गर्भनाशक सभी भावों को जानने में समर्थ होता है।

Minita (efficient cause) for conception, its *ātmā* (self), *prakṛti*, gradual development in uterus and factors responsible for growth are five auspicious features of conception. The factors responsible for non-achievement of conception (infertility), destruction of fetus and teratologic abnormalities are three inauspicious features or *garbhaviṅghāṭaka* (destructor of fetus) features. The physician who knows these eight auspicious or inauspicious features of conception is capable of treating the king. The physician possessing bounteous intellect is capable of understanding the methods of achievement of conception and causes of its destruction.

गर्भ के पूर्ण-काल में परिपूर्ण देह होकर सुख से उत्पन्न होने के कारण (Factors responsible for normal delivery of normally developed full term fetus)

शुक्रासृगामाशयकालसंपदं यत्सोपचारश्च हितैस्तथाऽन्यैः।

गर्भश्च काले च सुखी सुखं च सञ्जायते संपरिपूर्णदेहः ॥ (च० सं० शा० २/६)

शुक्र, अर्तव, आत्मा, अश्रय एवं काल आदि सभी संपत् या शुद्ध हो, गर्भिणी का हित अन्न आदि सेवन एवं अन्य उपचार (पञ्चाण्डव्य व्यवस्था) सम्पत् हो तो गर्भ संपरिपूर्ण देह का होकर सुखी या स्वस्थ रूप में, सुख से या बिना कष्ट के, परिपूर्ण काल में उत्पन्न होता है। टीकाकार चक्रवर्ती ने शुक्रार्तव आदि का दृष्ट न होना, आत्मा का शुभ जीव-कर्म से युक्त होना एवं काल का अतितीक्ष्ण न होना ही इन सभी का सम्पत् होना माना है।

If *śukra* (sperms), *artava* (ovum and ovarian hormones), *ātmā* (self), *dāśya* (uterus) and *kāla* (time factor) etc. all are perfect, dietetics and mode of life advocated for pregnant woman is followed properly, then the healthy, well grown fetus, possessing all his body parts will deliver with ease, at proper period. The perfection indicates the absence of any abnormality in *śukra* or *artava*, association of *ātmā* with *jīva* having good deeds to its credit and absence of very sharpness in *kāla* (time).

गर्भाशयान्तर गर्भ-स्थिति (Intrauterine situation of fetus)

गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्वशिखाः सङ्कुच्याङ्गान्वास्तेऽन्तःकुक्षौ ॥ (च० सं० शा० ६/२२)
आमुषोऽभिमुखः शेते गर्भो गर्भाशये स्त्रियाः ॥ (सु० सं० शा० ५/४५)

१. शुक्रासृगामाशयानामुद्वृत्तं संपदं, आत्मनस्तु शुक्रजीविनसंयोगादिशुद्धः शुभजीवकर्मयुक्तत्वं संपत्, कालस्य त्वन्तितीक्ष्णत्वादि संपत्। उपचारो गर्भिण्युपचारः ॥ (च० सं० शा० २/६ को चक्र० टी०)

गर्भस्तु मातुः पृष्ठाभिमुखो ललाटे कुलाङ्गलिः सङ्कुचितान्ष्टौ गर्भकोष्ठे दक्षिणपार्श्वमाश्रित्यावतिष्ठते पुमान् वामं स्त्री मध्यं नपुंसकम् ॥ (अ० सं० शा० २/३१)

गर्भ कुक्षि (गर्भाशय) के अन्दर माता के पीठ की ओर मुख, ऊपर की ओर शिर तथा सभी अङ्गों को संकुचित करके स्थित होता है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है स्त्रियों का गर्भ गर्भाशय में आपुन (अच्छी प्रकार घुका या संकुचित) एवं अभिमुख (माता के मुख के सामने मुख करके या पृष्ठाभिमुख) होकर शयन करता है (रहता है)।

अष्टाङ्गसंहकार ने लिखा है कि गर्भ माता की पीठ की ओर मुख करके, ललाटे में (मस्तक के पास) अवलि बानकर (दोनों हाथों को जोड़कर), अंगों को संकुचित करके गर्भाशय में रहता है। यदि पुरुष (पुत्र) है तो दक्षिण पार्श्व की आश्रय लेकर, यदि स्त्री (कन्या) है तो वाम पार्श्व तथा नपुंसक है तो मध्य में स्थित रहता है। (इस आशय का वर्णन अन्य आचार्यों ने गर्भिणी-चिह्नों के अन्तर्गत किया है)।

महर्षि भेल ने "गर्भ माता के पेट में किस प्रकार ठहरता है?" इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि शौनक के मतानुसार ऊर्ध्व शिर एवं भ्रूद्वज के मतानुसार अवाक्षिर (नीचे की शिर करके) रहता है। भगवान् पुनर्वसु आश्रय कहते हैं कि ऐसा नहीं है यदि ऊर्ध्व (शिर) स्थित होगा तो माता को मारक होगा यदि अवाक्षिर होगा तो स्वयं को मारक (प्राणघातक) होगा। तो किस प्रकार? सभी अंगों-प्रत्यङ्गों को संकुचित करके तिर्यक (स्थिति में) शयन करता है।^३
The fetus stays in uterus with all its body parts fully flexed and facing towards the back of the mother. Caraka has mentioned the position of head as upwards. Vāgbhata I has added that the fetus keeps its both palms joined together over its forehead and if it is male its situation is more on right lateral side of abdomen, if female then on left lateral side and if hermaphrodite then it remains centrally situated.

Bhela explaining the position of fetal head has said that Śaunaka and Bhardwāja have mentioned the situation of head as upwards and downwards respectively. However Punarvasu Ātreya has clarified that it is not so, if the head remains upwards it can kill the mother and if downwards then will kill himself, thus the position of head is neither upwards nor downwards, rather it is oblique.

विमर्श (Comments)

महर्षि चरक द्वारा वर्णित ऊर्ध्व-शिर का स्थितिकरण कठिन है क्योंकि सामान्य प्रसूत होने वाली स्त्रियों के गर्भ का शिर नीचे की ओर रहता है। गर्भ गर्भवस्था के ६ या ७ माह तक अस्थिर स्थिति में रहता है एवं अधिकांशतः शिर ऊपर की ही ओर होता है। गर्भवस्था के अंतिम त्रैमास में गर्भ अपनी निश्चित स्थिति ले लेता है। फिर भी नाण्य स्त्रियों में प्रसव के कुछ दिन पूर्व भी गर्भ की स्थिति में परिवर्तन देखा गया है। महर्षि चरक के वर्णन का आधार गर्भावस्था के ६-७ माह की परीक्षा या इन नाण्य स्त्रियों का वर्णन ही प्रतीत होता है। यदि शिर से शिरार्ध के ऊपर के भाग का (वृट्कस) ग्रहण करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में भी शिर अत्यधिक संकुचित नहीं होता जिसके कारण यह वृट्कस ऊपर अर्थात् ऊँचा प्रतीत होता है प्रसव के काल में शिर के अत्यधिक संकुचित

१. अध्याय ५ में देखें।

२. तत्राह कथं गर्भं मातुस्तरे तिष्ठतीति? ऊर्ध्वमिति शौनकः, अवाक्षिरा इति भद्राजः। नेत्याह भगवान् पुनर्वसुशब्देन। पश्युर्ध्वं तिष्ठतीह मातुर्माति(रः) स्यात्। यद्व्यावृत्त्याः, तदा स्वमाति(रः) स्यात्। कथं तर्हि? तिर्यक् सर्वैरयमा(ङ्ग)प्रत्यङ्गै प्रतिमुद्रः शेवे(ते) ॥ (अ० सं० शा० ४/३४)

हो जाने पर यह अंग सबसे नीचे गड़न जाता है।

Fetus remains in head down position in about 95.0% cases, which position is attained in last trimester of pregnancy, however, in exceptional cases the fetus may rotate to this position few days before delivery. Up to second trimester the fetus remains floating, thus head may remain even in flanks or upwards, probably Caraka and Bhela etc. have related to this very situation. However, if with word 'siras' instead of head 'vertex' is considered then description becomes clearer, because before labour the vertex remains higher than the sinuiput, while it descends down at the time of delivery due to flexion of head.

पुंसवनकर्म (Punṣavakarma)

ईच्छित पुमान् सन्तान-प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विभिन्न कर्म पुंसवन कर्म कहलाते हैं। इस कर्म के करने के समुचित काल एवं विधियों का आचार्यों ने विस्तृति वर्णन दिया है।

The procedure to be adopted for achieving progeny of desired sex is known as *punṣavana karma*. The classics have described its appropriate period alongwith the methods.

पुंसवनकर्म-उपयुक्त काल (Appropriate period for punṣavana karma)

तथा: कर्मणा वेदोक्तैः विवर्तनमुपदिश्यते प्राण्यक्तीभावात् प्रयुक्तेन समयक। कर्मणा हि देशकालसंपदुपेतानां नियतिमिष्टफलत्वं, तथैवेवाभितत्त्वम्। तस्मात्पुनर्गर्भा स्त्रियभिर्भसमीक्ष्य प्राण्यक्तीभावाद्गर्भस्य पुंसवनसमये दद्यात्॥

(च० सं० शा० ८/१९)

लब्धगर्भावाञ्छेतु (सु० सं० शा० २/३२)

लब्धगर्भा चैनां विदित्वा प्राण्यक्तीभावाद्गर्भस्य पुष्य पुंसवनादि प्रयुञ्जीत। द्वादशरात्रमिन्त्यस्ये। तत्रापि युग्मदिनेष्विति केचित। प्रत्यहमिन्त्यपरे ॥ ६०॥

अविरुद्धे ध्रुवं दैवे काले युक्तस्य कर्मणः। सिद्धिः पुंसवनाद्यस्मात्पूर्वं व्यक्तेः प्रयोजयेत् ॥ ६१॥

(अ० सं० शा० १/६० एवं ६१)

गर्भः पुंसवनाद्यत्र पूर्वं व्यक्तेः प्रयोजयेत्। बली पुरुषकारो हि दैवमप्यतिवर्तते ॥
(अ० ह० शा० १/३७ एवं ३८)

उन दोनों में (कन्या या पुत्र में) वेद (आयुर्वेद) में वर्णित विधियों का सम्यक् प्रकार से, व्यक्तीभाव (गर्भ के लिंग निर्णायक व्यक्तता के चिह्न) उत्पन्न होने के पूर्व प्रयोग करने से परिवर्तन करना सम्भव है। देश, काल आदि की अनुकूलता के आधार पर किया गया कर्म (पुंसवन कर्म) निश्चित ही फल देता है, विपरीत होने पर विपरीत (अर्थात् अनुचित देश या अनुचित काल में किया गया कर्म वांछित फल नहीं देता)। अतः स्त्री को आपन्नगर्भा (गर्भवती) समझकर व्यक्तीभाव होने के पूर्व पुंसवन कर्म करावें। टीकाकार चक्रपाणि ने व्यक्त-भाव के पूर्व का काल द्वितीय मास तक का माना है एवं इस काल तक पुंसवन कर्म करने का विधान बताया है^१।

१. पुंसवनीमिति पुंस्त्वकारकं कर्म ॥ (च० सं० शा० ८/१९ की चक्र० टी०)

२. व्यक्तिसु द्वितीये मासे भवति; यदुक्तं-“द्वितीये मासे घनः संपद्यते” इत्यादि; किंवा तृतीये मासे अङ्गप्रत्यङ्ग-भिव्यक्तेर्व्यक्तीभावो ज्ञेयः; द्वितीये तु मासे ग्रन्थ्यादिरूपे गर्भे प्रत्यङ्गव्यक्तीभावो न व्यक्तः, तेन वक्ष्यमाणं कर्म मासद्वयं यावत् कर्तव्यम् ॥ (च० सं० ८/३९ की चक्र० टी०)

महर्षि सुश्रुत ने केवल लब्धगर्भा कह कर ही विषय को छोड़ दिया है पर टीकाकार उत्तरुण ने स्पष्टीकरण देते हुए नस्य आदि कर्मों को तीन विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी बताया है (१) गर्भ की उपलब्धि से पूर्व गर्भ-ग्रहण के लिए इन नस्य आदि का प्रयोग कर तब ग्राभ्यधर्म-सेवन (गर्भ की प्राप्ति हेतु) (२) लब्धगर्भा होने पर गर्भ के स्थापन के लिए एवं (३) तीन मास का गर्भ होने के पूर्व पुनोपति के लिए^१। अन्यत्र शुक्रार्तवाद्बहुल्य से ही पुत्र-पुत्री उत्पत्ति के वर्णनान्तर्गत लिखा है कि पुत्रीयविधि निरर्थक नहीं है, क्योंकि बिना श्रेष्ठकर्म के रूपादि से युक्त पुत्र की प्राप्ति नहीं होती^२।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि स्त्री को लब्धगर्भा जानकर व्यक्तीभाव होने के पूर्व पुष्य नक्षत्र में पुंसवनकर्म का प्रयोग करना चाहिए। कुछ आचार्यों का मत है कि यह पुंसवन का प्रयोग बारह दिन तक करना चाहिए। इन बारह दिनों में भी युग्म दिनों में प्रयोग करें ऐसा भी किन्हीं-किन्हीं आचार्यों का मत है। अन्यो का कथन है कि प्रतिदिन इस पुंसवन का प्रयोग करना चाहिए। टीकाकार इन्द्र ने केवल प्रथम दिन, युग्म दिनों में, प्रत्येक दिन एवं बारह दिनों के युग्म दिन आदि चार विकल्प पुंसवनकर्म-प्रयोग के लिए दिए हैं^३। दैव (भाग या पूर्वजन्म-कर्म) के अनुकूल होने पर, उचित समय में प्रयुक्त कर्म (पुंसवन) निश्चित सफलतादायक होता है अतः फल-सिद्धि के लिए गर्भ की व्यकावस्था के पूर्व युकिपूर्वक पुंसवनकर्म का प्रयोग करे (भाग के विरुद्ध होने पर युकिपूर्वक किया गया भी पुंसवनकर्म निष्फल हो जाता है)।

अष्टाङ्गहृदयकार का कहना है कि गर्भ के लक्षण व्यक्त होने के पूर्व (स्त्री या पुरुष के लिंग-लक्षण व्यक्त होने के पूर्व) पुंसवनकर्म का प्रयोग करना चाहिए। बलवान पुंसवनकर्म दैव (भाग) को भी परिवर्तित कर देता है। टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है कि जिस प्रकार बलवान पुंसवनकर्म दैव को परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार बलवान दैव पुंसवनकर्म को निष्फल कर देता है; अतः सम्यक् प्रयोजित पुंसवनकर्म की सफलता प्राकृत-कर्म के हीनबलत्व या प्रबलत्व के ऊपर आधारित होती है^४।

If the methods prescribed in *vedas* for achieving male or female progeny are used before the conspicuousness (*vyaklihbhava*) of organs the change of sex is possible. If the *punṣavana karma* is done keeping in mind the living place (*deśa*) and specific period (*kāla*) the result is definite, otherwise it is just reverse (if due consideration to *deśa* and *kāla* is not given then sex may not change). *punṣavana karma* should be done after conception but before conspicuousness of organs or upto two months.

Suśruta has advocated that it should be done just after achievement of conception (*labdhigarbhā*). Dāhāna has explained that this process is done with three objectives (1)

१. चकारादलब्धगर्भायाः पूर्वमेव लक्षणपादितानां नस्यदानं सहस्राभिर्दुतं गर्भग्रहणाय पश्चाद् ग्राभ्यधर्मसेवनीमिति १-.....।

लब्धगर्भायाश्च लभ्यमाणदिनस्यदानं गर्भस्थापनार्थं, स्थितागर्भायाश्च मासत्रयात्पनरौ पुत्रापचयजननार्थं नस्यदानमिति ॥

(सु० सं० शा० २/३२ की डह्ल० टी०)

२. यद्येवं तर्हि प्रागुक्तं पुरीयकाणां निरर्थकं ? नैतदस्ति, किन्तु श्रेयसा कर्मणा विना नैव रूपसिद्धिमिनो भवन्ति पुत्राः ॥

(सु० सं० शा० ३/५ की डह्ल० टी०)

३. प्रथमेश्चि केचित् पुंसवनीच्छन्ति, तत्राप्ययुग्मदिनं विभागायुग्मेषु दिनेष्विति केचित् प्रवदन्ति, केचित्तन्नाकारः प्रत्यहं पुंसवनीच्छन्ति,, केचित् द्वादशरात्रयैव युग्मदिनेष्विति विशेषाभिप्रायन्ति ॥ (अ० सं० शा० १/६० की इन्द्र टी०)

४. पुरुषकारो बलवान् दुर्बलं दैवमतिवर्तते। अपिसाब्दत् पुरुषकारमपि दुर्बलं दिष्टं बलीयोऽतिक्रम्य वर्तते इति प्रतिपादयति। अतएव प्राकृतेन कर्मणा बलीयसाऽऽश्लिष्यत्य स्त्रीभस्य पुंसवनादितानेन पीरयेण कर्मणा शतशोऽपि प्रयोजितेन न कथाश्चिपुर्भूता कर्तुं शक्यते इति। उक्तं च “दैवं पुरुषकारेण दुर्बलं ह्युपहृत्यते। दैवेन चेतकर्म प्रकृष्टेनोपहृत्यते।” इति। अत्र पुंसवनादि सम्यक् प्रयोजितं सिद्ध्यासिद्धयनुपीयमानं प्राकृतस्य कर्मणो हीनबलत्वप्रबलत्वमवगमयति ॥

(अ० ह० शा० १/३७, ३८ की अरुण० टी०)

before conception use of inhalation of drugs etc. followed by coitus is for achievement of conception. (2) immediately following conception is for its proper implantation and (3) before three months for change of sex or for having male progeny.

Vāgbhata I corroborating the period given by Caraka says further that it should be done only during *pūṣya nakṣatra*. Citing the opinions of others, he says that some advise the duration of *pūṣya nakṣatra* for twelve days, others during even days of these twelve days, while some advise its daily use. Indu has given four options: (1) only on first day (2) on even days, (3) daily (4) every even day of twelve days period. Further he says that success depends upon the favour of luck.

Vāgbhata II agreeing with the period i. e. before consciousness of body parts says that potent *pūṣya nakṣatra* can alter the luck. Arunadatta has explained that as a potent *pūṣya nakṣatra* can alter the luck, similarly potent luck can make the *karma* unsuccessful, thus the success of *pūṣya nakṣatra* depends upon relative strength of luck.

विमर्श (Comments)

गर्भाधान करने वाले शुक्राणु का लिङ्ग गुणसूत्र निश्चित होता है, अतः गर्भाधान के परचात प्रयुक्त किसी भी विधि से गर्भ के लिङ्ग परिवर्तन की सम्भावना नहीं रहती। अष्टाङ्गसंग्रह वर्णित बाह्य दिन की समय सीमा सम्भवतः ऋतुकाल को इंगित करती है। टीकाकार डल्हण ने औषधि प्रयोग का काल ग्राम्यधर्म सेवन से पूर्व स्पष्टकर लिखा है^१। 'प्राक्कल्पोभाव' से भी गर्भ व्यक्तीभाव अर्थात् गर्भाधान (शुक्र शोणित संयोग के पूर्व) के पूर्व अर्थ कर सकते हैं। यह सम्भव है कि ऋतुकाल अर्थात् गर्भाधान के पूर्व किया गया पुंसवन कर्म स्त्री-शरीर विशेषकर स्त्रीबीज में इस प्रकार के परिवर्तन कर दे कि वह वांछित शुक्राणुओं को ही आकर्षित कर प्रविष्ट होने दे।

An ovum is fertilized by the sperm of specific sex chromosome, naturally after fertilization the chances of reversal of sex by any procedure does not seem to be possible. The time limit of twelve days given by Vāgbhata I probably refers to *ṛukāla*. Dalhana has mentioned the period of use of drugs before coitus in unequivocal words. The description before conspicuousness of body-parts can be considered as before conspicuousness of *garbha* i.e. before fertilization of ovum by sperms. It is hypothetically possible that specific procedure done before fertilization may produce some such changes in female body specially in ovum, that it attracts or permits its penetration by specific sex chromosome bearing sperms only.

पुंसवन विधि (Methods of pūṣya nakṣatra)

गोष्ठे जातस्य न्यग्रोधस्य प्रागुत्तराभ्यां शाखाभ्यां शुद्धे अनुवृत्ते अदाय द्वाभ्यां धान्यमाषाभ्यां संतुदुपेताभ्यां गौरसर्पणभ्यां वा सह दक्षि प्रक्षिप्य पुष्पेण पिबेत्, तथैवापराश्रीवर्कभकापागर्भाहचरकल्कांश्च युगादेकैकशो यथेष्टं वाऽप्युपसंस्कृत्य पयसा, कुड्मकीटक मत्स्यं बोदकाञ्जलीं प्रक्षिप्य पुष्पेण पिबेत्, तथा कनकमयान्, राजतानायासांश्च पुरुषकानि शिवानि नृपमाणान् दक्षि पयस्युदकाञ्जलीं वा प्रक्षिप्य पिबेदन्वशेषतः पुष्पेण, पुष्पेणैव च शान्तिपिष्टस्य पच्यमानस्योष्माणमुपाधाय तस्यैव च पिष्टस्युदकासंस्पृश्य रसं देहल्यामुपनिधाय दक्षिणे नासागुटे स्वयमासिञ्चेत्

१. सु० सं० शा० २/३२ की डल्हण टीका (पुंसवन विधि के अन्तर्गत उद्धृत)

चिन्तना । यच्चान्यदपि ब्राह्मण ब्रह्मसूत्राणां वा स्त्रियः पुंसवनमिष्टं तच्चागुष्टेयम्। इति पुंसवनानि ॥

तद्यथा-लक्ष्मणावटशुद्धसहदेवाविश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेभिर्भुज्य ब्रौञ्जगते वा बिन्दुन् दक्षिणे नासागुटे स्वयमासिञ्चेत्चिन्तना वामे वा दुहितुकामा । न चैताविशीवेत् । तथा पुष्पोद्भूतायाः श्वेतवृद्धत्या मूलकल्काद्रसं नावयेत् । तद्वन्येयत्वाय कुमुदपत्रं लक्ष्मणामूलं वटशुङ्गानि चाष्टौ च नावयेत् । शुक्लमाल्यान्तरया च नारी पुष्पोद्भूताया लक्ष्मणाया मूलकल्कमुदन्तरामात्रं पयसा पिबेत्पुत्रस्योत्पादाय स्थितये च । तद्वन्तरादण्डमपामार्गं जीवकपर्षकौ शङ्खपुष्पौ मध्यदण्डौ सहचरं नगर्वावमश्रिजिह्वाभ्यां वा वा वटशुङ्गानि । पिष्टस्य च पच्यमानस्योष्माणमुपाधाय तद्रसं देहल्यां स्थितौ पूर्ववत्नावयेत् । यच्चान्यदपि ब्राह्मणा वृद्धिस्त्रियो वा ब्रह्मस्तस्य कुर्यात् ॥ (अ० सं० शा० १/६१)

(सु० सं० शा० २/३२)

तद्यथा-लक्ष्मणावटशुद्धसहदेवाविश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेभिर्भुज्य ब्रौञ्जगते वा बिन्दुन् दक्षिणे नासागुटे स्वयमासिञ्चेत्चिन्तना वामे वा दुहितुकामा । न चैताविशीवेत् । तथा पुष्पोद्भूतायाः श्वेतवृद्धत्या मूलकल्काद्रसं नावयेत् । तद्वन्येयत्वाय कुमुदपत्रं लक्ष्मणामूलं वटशुङ्गानि चाष्टौ च नावयेत् । शुक्लमाल्यान्तरया च नारी पुष्पोद्भूताया लक्ष्मणाया मूलकल्कमुदन्तरामात्रं पयसा पिबेत्पुत्रस्योत्पादाय स्थितये च । तद्वन्तरादण्डमपामार्गं जीवकपर्षकौ शङ्खपुष्पौ मध्यदण्डौ सहचरं नगर्वावमश्रिजिह्वाभ्यां वा वा वटशुङ्गानि । पिष्टस्य च पच्यमानस्योष्माणमुपाधाय तद्रसं देहल्यां स्थितौ पूर्ववत्नावयेत् । यच्चान्यदपि ब्राह्मणा वृद्धिस्त्रियो वा ब्रह्मस्तस्य कुर्यात् ॥ (अ० सं० शा० १/६१)

पुष्पे पुरुषकं हैमं राजतं वाऽथवाऽप्यसम् ॥ ३८ ॥

कृत्वाग्निवर्णं निर्वाय क्षीरे तस्याञ्जलिं पिबेत् । गौरदण्डमपामार्गं जीवकपर्षकैर्वर्कान् ॥ ३९ ॥
पिबेत्पुष्पे जले पिष्टानेकद्वित्रिसप्तसंशः । क्षीरेण श्वेतवृद्धतीमूलं नासागुटे स्वयम् ॥ ४० ॥
पुनार्थं दक्षिणे सिञ्चेद्गामे दुहितुवाञ्छया । पयसा लक्ष्मणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिपदम् ॥ ४१ ॥
नासायाऽऽप्येन वा पीतं वटशुङ्गादकं तथा । औषधीर्वाजीवाश्व बाह्यान्तरपयोजयेत् ॥ ४२ ॥

(अ० सं० शा० १)

गोष्ठे या गौओं के विश्राम स्थान पर उत्पन्न वट वृक्ष की पूर्व एवं उत्तर की ओर की दो शाखाओं से दो अनुवृत्त (अविकृत या अशुण्ण) शुद्ध लेकर, सम्पत् (सामान्य रस, शुभ वीर्य आदि युक्त) दो ब्रीहि माष या सुवर्ण माष अथवा पीले सर्प (के दाने) लेकर दही के साथ मिलाकर पुष्प नक्षत्र में पीये । इसी भाँति (गोष्ठोत्पन्न) जीवक, ऋषभक, अपामार्ग, सहचर सभी के कल्क को, वांछित कुछ द्रव्यों अथवा अलग-अलग एक-एक द्रव्य के कल्क को दुग्ध के साथ संस्कृत करके इच्छानुसार (पुष्प नक्षत्र में) पीये । कुड्मकीटक या मत्स्य को एक अञ्जली जल में डालकर पुष्प नक्षत्र में पीये । स्वर्ण, राजत अथवा लोहे की अणु-प्रमाण (अत्यन्त सूक्ष्म), अग्निवर्ण की (आग में तपाने से लाल हो गई हुई) पुरुषकृति को एक अञ्जलि दधि अथवा उदक में प्रक्षिप्त करके बिना बचाए हुए सम्पूर्ण ही पुष्प नक्षत्र में पीए; पुष्प नक्षत्र में ही पकाई जाती हुई शान्तिमिष्टि (जल के साथ पीसा हुआ शान्ति चावल) की ऊष्मा (वाष्प) को सूँघकर, उसी मिष्टि के ही जल-संस्पृष्ट होने से उत्पन्न रस को पियु द्वारा देहली (गृहद्वार का अधःकाष्ठ) में सिर रखकर अपने हाथ से ही दक्षिण नासागुटे में डाले । इसके अतिरिक्त अन्य जो भी ब्राह्मण, आराज्य या स्त्रियाँ पुंसवन-उपयोगी-कर्म करें वहाँ वहाँ करें । यह पुंसवन विधि समाप्त हुई ।

महर्षि सुश्रुत ने बहुत ही संक्षेप में पुंसवन-विधि का वर्णन किया है कि इन दिनों में गर्भ को प्राप्त हुई अर्थात् गर्भाणी-स्त्री लक्ष्मणा, वटशुङ्ग, सहदेवा (पीतबला या कपी), विश्वदेवा (श्वेतबला या गोरुस्त्री) आदि अन्य औषधियों की क्षीर (गौ दुग्ध) के साथ पीस कर पुत्र की इच्छा होने पर तीन या चार बूँद दक्षिण नासागुटे में डाले, उसे थूके नहीं । पाद-टीका में कन्या की इच्छा से वाम नासागुटे में डालने का उल्लेख है । टीकाकार डल्हण ने पुष्प-फल-युक्त लक्ष्मणा की शाद ऋतु में शनिवार की सन्ध्याकाल के पुष्प योग में मन्त्र पूर्वक उद्धृत करके, उसके (लक्ष्मणा के) चतुर्मास (चौपाई भाग) खदिर के कोलकों (मूलों) को दूसरे किसी भी दिन हस्त मूल या पुष्प नक्षत्र में सूर्यास्त के बाद मन्त्र-पूर्वक खोदकर समान वर्ण के बछड़े वाली गौ के क्षीर के साथ नस्य-प्रयोग का विधान बताया है । गर्भ-प्राप्ति के लिए ग्राम्यधर्म-सेवन

१. धान्यमाषाश्वेन ब्रीहिमाषं, ग्राहयन्ति, सुवर्णमाषं चच्चावर्तयन्ति। (च० सं० शा० ८/१९ की चक्र० टी०)

के पूर्व इसके प्रयोग का वर्णन करते हुए लिखा है कि औषधि के नासापुट में सेवन के पश्चात् क्षीर एवं अंदन के भोजन का क्रम पाँच दिन तक कर पश्चात् गायधर्म का सेवन करें।^१ सम्भवतः इस विधि से गर्भ की प्राप्ति होकर पुत्र ही उत्पन्न होता हो।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने चरक एवं सुश्रुत-वर्णित औषधियों का ही वर्णन किया है यथा-लक्ष्मणा, वटशुङ्ग, सहदेवा एवं विश्वदेवा आदि अन्य औषधियों को क्षीर (गोदुग्ध) के साथ पीसकर (प्रातः रस को) स्वयं ही पुत्र की इच्छा से दक्षिण नासापुट में एवं पुत्रों की इच्छा से बायें नासापुट में तीन बार बूँद डाले, इसे धूँके नहीं। पुष्प नक्षत्र में उखाड़ी गई श्वेतवृहती-मूल-कल्क-म्यरस का नम्य ले। इसी प्रकार उत्पल पत्र, कुमुद पत्र, लक्ष्मणा मूल या आठ वटशुङ्गों का नम्य ले। श्वेत माला एवं वन भागण को हुई स्त्री (गर्भिणी स्त्री) पुष्प नक्षत्र में उखाड़ी गई लक्ष्मणा के मूल-कल्क को उदुम्बर-फल की माता में तंकरा पुत्र की उत्पत्ति एवं व्यक्तवस्था में पुत्र-गर्भ की स्थिति एवं रक्षा के लिए दुग्ध (गोदुग्ध) के साथ पीये। इसी प्रकार गौरपण्ड अपामार्ग, जीवक, ऋषभक, शङ्खुपुष्पी, मध्यादण्ड (अध्याण्ड या कपिकच्छू) सहचार, नगजीव, अग्निविज्ञा अथवा आठ वटशुङ्गों का प्रयोग करें। पिष्टी (शांति पिष्टी के पिण्ड) के पकाए जाते समय निकलने वाले धूम तथा उसके रस को देहलो में स्थित होकर (वैठकर) पूर्व की ही भाँति प्रयोग करें तथा अन्य जो भी ब्राह्मण या वृद्ध स्त्रियाँ बताएँ वह करें।

अष्टाङ्गहव्यकार ने महर्षि चरक सदृश ही अधिकांश वर्णन दिया है। स्वर्ण, रजत या लौह की बनी पुरुषाकृति को अग्नि वर्ण करके (अग्नि में तापकर लाल करके) क्षीर में बुझाकर उस क्षीर की अंजली मात्रा का पान करें। गौरपण्ड अपामार्ग, जीवक, ऋषभक, सैर्वक में से एक, दो, तीन या सभी को लेकर पुष्प नक्षत्र में जल से पीये। श्वेत कण्टकारी-मूल को दुग्ध में पीसकर पुत्र की इच्छा से दक्षिण नासापुट में या पुत्रों की इच्छा से बायें नासापुट में स्वयं ही अग्निघ्नन करें (तीन या चार बूँद डालें)। क्षीर के साथ लक्ष्मणा-मूल को पीसकर नासा या मुख से पीने से पुत्र की उत्पत्ति होती है एवं गर्भ भी स्थिर होता है। इसी भाँति आठ वटशुङ्ग का प्रयोग भी किया जाता है। यह आठ की संख्या प्रभाव की अचिन्त्यता के कारण दी गई है। जीवनीयाण को औषधियों का बाह्य (सानोद्वर्नगदि) तथा आन्तर्य (आहार-पानादि) उपयोग करना चाहिए।

भगविमित्र ने निम्न योगों का वर्णन दिया है।^१

१. लक्ष्मणा..... तं च शरत्काले पुष्पफलोपेतौ दृष्ट्वा शनिदिने सन्ध्यायां तस्याश्चतुर्भाषीषु खट्विरकालकात्रिंशत्वापरेषु-हैलमूलपुष्पशैवीणां गते दिवाकरे मन्त्रवद् गृहीत्वा समानवर्णवत्सया गोः क्षीरेण यथाविधि नम्यं दद्यात् ।.....॥ चकारात् लक्ष्मणाभ्याः पूर्वमेव लक्ष्मणादीनां नम्यदानं सहस्राभिहुतं गर्भाग्रहणाय पश्चाद् गायधर्मसेवनमिति । तदुक्तं तन्त्रान्तरे-“पूर्वमेव सहस्राभिहुतं कृत्वा माङ्गल्यदेशे गोः क्षीरेण पेरयित्वा तस्माद् त्रीन बिन्दुं दक्षिणे नासापुटे दद्यात्, न निश्चिक्ते तान् काण्डप्रस्रात्, सा पश्चदिनाति पर्यसीदनमश्रीयात् तदूर्ध्वं गायधर्मसेवनम् ॥ (सु० सं० शा० २/३२ की डल्ल० टी०)
२. लक्ष्मणाभ्यां पीते व्यक्तवस्थां पुत्रस्य परित्यागं रक्षामिषान् स्थितिं करोति । (अ० सं० शा० १/६१ की इन्दु टी०)
३. पानमेतं न अल्पाण्डा (इन्दु टीका पुस्तक) का प्रयोग है। यह द्रव्य अध्याण्ड या कपिकच्छू होता है।
..... शङ्खुपुष्पोमय्याण्डा सहचरश्रग्विलमग्निजिह्वामधौ वा वटशुङ्गानि। शालिपिष्टस्य॥
(अ० सं० शा० १/६१ का पाठभेद इन्दु टीका की पुस्तक में)
४. नासाऽऽस्येन वा-कदाचिनासिकया कदाचिदास्येन ।..... प्रभावस्याचिन्त्यतेऽस्तच्छावच्छिन्नम् ॥
(अ० ह० शा० १/४२ की अरण्य टी०)
५. पत्रमेकं पलाशस्य पिष्ट्वा दुग्धेन गर्भिणी । पीत्वा पुत्रमाप्नोति वीर्यवन्तं न संशयः ॥
शूकरशिन्धोमूलं मय्य वा दीधफलस्य सपरस्कम् । पीत्वाऽथ भवतिङ्गीबीजं कन्यां न सूते स्त्री ॥
पुत्रकमञ्जरमूलं विष्णुजान्तेयलङ्किनीं सहिता । एतद्भेदोदितं पीत्वा कन्यां न सर्वथा सूते ॥
(भा० प्र० चि० ७०/३० से ३२)

- (१) गर्भिणी एक पलाश पत्र को दुग्ध के साथ पीसकर पान करें।
- (२) शूकरशिन्धो मूल या दीधफल (कपित्थ) के गूदे को अथवा भवलिङ्गी (ईश्वरलिङ्गी) के बीजों को दुग्ध के साथ पीसकर पान करने से स्त्री (कभी भी) कन्या उत्पन्न नहीं करती अर्थात् पुत्र ही उत्पन्न करती है।
- (३) पुत्रमञ्जरी (पतित्ज्या) की मूल एवं विष्णुकान्ता की मूल को ईश्वरलिङ्गी (शिवलिङ्गी के बीजों) के साथ गणवत्स्य में आठ दिन पीने से कन्या कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकती अर्थात् पुत्र ही उत्पन्न होता है।
योगालाकार ने योनिव्यापिचिकित्सा अध्याय के अन्त में कतिपय योगों का उल्लेख किया है जिनमें अधिकांशतः तो गर्भस्थाक अर्थात् बन्धन्य की चिकित्सा के लिए वर्णित प्रतीत होते हैं। जिनका प्रभाव स्पष्ट रूप से पुत्रोत्पादक ही लिखा हुआ है वे निम्न हैं।^१

- (१) भाव प्रकाश वर्णित प्रथम दो योग ।
- (२) श्वेतवृहतीमूल को क्षीर के साथ पीसकर पुत्रेच्छा से दक्षिण नासापुट से एवं कन्या की इच्छा से बायें नासापुट से पान ।
- (१) Two intact, healthy leaf-buds (*śūṅga*) plucked from two eastern or northern branches of a banyan tree grown in a cowshed, along with two perfect (possessing good *rasa*, *vīrya* etc.) seeds of *dhyānya māṣa* (a kind of kidney bean) and *gaura sarṣapa* (yellow mustard) should be taken with curd during *pusya nakṣatra*.
- (2) Similarly the paste of *jīvaka*, *ṛṣabhaka*, *apāmārga* and *sphacara* etc. (plants grown in a cowshed) collectively, individually or few of them should be taken (during *pusya nakṣatra*) after treating (cooking or mixing) these with milk.
- (3) *Kudākāya* (an insect making abode with wet soil to seal other small insects and laying its eggs) and fish mixed with one *āyāli* (handful) of water should be taken during *pusya nakṣatra*.
- (4) An *anupramāṇa* (very small) red hot man shaped structure made with gold, silver or iron, should be dipped in handful of curd, milk or water and total quantity should be taken during *pusya nakṣatra*.
- (5) The woman should inhale the steam of *sāl piṣṭi* (dough of rice or pestered rice) being cooked during *pusya nakṣatra*. The same dough should be squeezed and the juice collected in swab. The pregnant woman keeping the head on a doorsill should instill herself few drops from this swab in her right nostril.
- (6) Other measures suggested by *bṛāhmaṇas*, senior persons and ladies should be followed.
- (7) The drug *lakṣmaṇā*, *vaiṣṭuṅga* (leafbuds), *sahadevā*, *viśvadevā* etc. should be pestered with cow's milk, and 3-4 drops of expressed juice should be instilled in right nostril by the woman desirous of a son; she should not spit it.
- (8) Observing flowers and fruits on the *lakṣmaṇāya* plant during *śarvada rāu* (early winter

१. पत्रमेकं पीत्वाऽथ भवलिङ्गीबीजं न (भा० प्र० सदृश ही)

क्षीरेण श्वेतवृहतीमूलं नासापुटे पिक्वेत् । पुत्रार्थं दक्षिणा नासा बायया कन्यकाधिनी ॥ (यो० १० योनिव्यापिचिकित्सा)

season), it should be uprooted during *pusyavarga* of Saturday's evening with enchantation of *mantras*. On some other day, after sunset during *hastamūla* or *pusya nakṣatra* the *khadirakīlaka* (roots of *khadira*) should be dug enchanting *mantra* in 1/4 quantity of *lakṣmanā*. Both these should be pestled with milk of cow having calf of similar colour, and a few drops of it should be instilled in right nostril.

9) The woman desirous of a son or daughter should instil herself in right or left nostril respectively, the juice expressed from pestled root of *śvetabhrāt* uprooted during *pusya nakṣatra*. Similarly leaves of *wipala* and *kumuda*, root of *lakṣmanā* and eight *vaśiṣṭha* should be used.

10) The woman wearing white garland and garments should take pestled root of *lakṣmanā* uprooted during *pusya nakṣatra*, in the quantity identical to fruit of *udumbara*, with cow's milk for getting a male child. Similarly *gauradāṇḍa* *capmārga*, *jīwaka*, *ṛṣabhaka*, *śāṅkhapuṣpi*, *adhyandā* or *karpikacchū*, *śahacārā*, *nagnajīwā*, *agujīthiwā* and eight leaf-buds of *vaṭa* should be used individually or two or three together.

11) The root of *lakṣmanā* pestled with cow's milk should be taken orally or through nostril for achievement of son, similarly leaf-buds of *vaṭa* should also be used.

12) The drugs of *jīwānyā* group should be used externally or orally.

13) One leaf of *palāśa* should be taken orally with milk.

14) The woman using root of *śūkarāśimbi* or pulp of *dadhīphala* (*kapitha fruit*) or seeds of *iṣwaringī* pestled with milk never delivers a girl but always a boy.

15) Oral use of root of *putramānjari* and *viṣṇukrāntā* and seeds of *iṣwaringī* for eight days during pregnancy never results in birth of a girl or always a son is born.

Note: preparation No. 8 is also prescribed for achievement of conception. After instilling it into nostril the woman should take rice and milk for five days, then have marital relations. Preparation No. 10 and 11 taken after conspicuousness of all body parts of embryo help in maintenance of pregnancy. Number of leaf-buds of *vaṭa* as eight is given as this number has inconceivable activity.



अध्याय ५

CHAPTER V

गर्भिणी-चिह्न एवं गर्भिणी-परिचर्या

(SIGNS / SYMPTOMS OF PREGNANCY AND ANTENATAL CARE)

गर्भिणी-लक्षण (Signs / symptoms of pregnancy)

(अ) सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण (Signs / symptoms of sadyograhita garbhā or immediately conceived woman)

निष्ठिविका गौरवमङ्गसादस्तन्नाग्रहर्षो हृदये व्यथा च ।

तुषिश्च बीजग्रहणं च योस्यां गर्भस्य सद्योगृहीतस्य लिङ्गम् ॥ (च० सं० शा० २/२३)

तत्र सद्योगृहीतगर्भाया लिङ्गानि-श्रमो न्तानिः पिपासा सक्थिमदन्तं शुक्रशोणितयोवबन्धः स्फुरणं च योनेः । (सु० सं० शा० ३/१३)

अथ नार्थाः सद्योगृहीतगर्भायाश्च लिङ्गं योस्या बीजग्रहणं तुष्मिणिमा स्फुरणं शुक्रार्तवयोरननुबन्धश्च । तथा ग्रहर्षो हल्लासस्तन्नाग्रहसदः प्रसेको हृदयव्यथा न्तानिः पिपासा च ॥ (अ० सं० शा० २/८)

लिङ्गं तु सद्योगर्भाया योस्या बीजस्य सङ्ग्रहः ॥ ३७ ॥

तुष्मिणित्वं स्फुरणं शुक्रासाऽननुबन्धनम् ॥

हृदयस्पन्दनं तन्ना तृडलानिर्लोमहर्षणम् ॥ ३८ ॥ (अ० ह० शा० १/३७, ३८)

निष्ठिवन (बार बार झुकना), गौरव (शरीर का भारोपन) अंगों में शैथिल्य, तन्ना, ग्रहर्ष, हृदय-प्रदेश में वेदना, तुष्मि, योनि द्वारा बीज-ग्रहण ये सभी सद्योगृहीत गर्भ या सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण हैं ।

महर्षि सुश्रुत ने सद्योगृहीत गर्भा के ये लक्षण लिखे हैं यथा-श्रम या थकान की अनुभूति, न्तानि, तृष्णा, सक्थियों में शैथिल्य, शुक्र एवं शोणित का अवबन्ध तथा योनि-स्फुरण ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने महर्षि चरक एवं सुश्रुत दोनों ही आचार्यों के वर्णनों का सामंजस्य कर दिया है इनके मतानुसार योनि में बीज-ग्रहण, तुष्मि, गरिमा या भारोपन एवं स्फुरण (अंगों में), शुक्रार्तव का अननुबन्ध या रुकावट, ग्रहर्ष, हल्लास या जी मिचलना, तन्ना, अंग-शैथिल्य, प्रसेक या मुख से थूक आना, हृदय-प्रदेश में व्यथा, न्तानि तथा पिपासा सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण हैं । टीकाकार इन्द्र ने अननुबन्ध से शुक्र एवं आर्तव का परस्पर अननुबन्ध अर्थात् गर्भ का विदारणादि से प्रतिबन्ध होना माना है^१ ।

अष्टाङ्गहृदयकार के मतानुसार सद्योगृहीतगर्भा के लक्षण योनि में बीज-संग्रह, तुष्मि, गुरुत्व, स्फुरण, शुक्रार्तव का अननुबन्ध या अप्रवर्तन, हृदय-स्पन्दन, तन्ना, प्यास, न्तानि एवं लोमहर्ष आदि हैं ।

१. गुरुत्वमङ्गस्य तत्सौव स्फुरणं चालनम्, शुक्रस्यार्तवस्य वा परस्परस्पन्दनानुबन्धनम् । अननुबन्धनं गर्भाविदारणादिना प्रतिबन्धः ॥ (अ० सं० शा० २/८ की इन्द्र टी०)

आचार्य भावमिश्र ने भी महर्षि सुश्रुत सदृश ही वर्णन दिया है^१।

Caraka has mentioned spitting (repeated), heaviness, malaise (*āṅgasāda*), sleepiness, horripilation, pain in cardiac region, contentment, seizure of seed in yoni etc. sings / symptoms of recently conceived woman.

Suśruta has mentioned fatigue, languor, thirst (excessive), lassitude of thighs, retention of *śukra* and *śoniya* (in yoni or absence of menstrual and coital discharges) and quivering in vagina etc.

Both Vāgbhata and Bhāvamīśra have also given almost above signs / symptoms, besides Vāgbhata has included nausea and excessive salivation in the list. Hindu has explained that association of *śukra* and *śoniya* with each other prevents destruction of embryo.

(आ) व्यक्तार्थ के लक्षण (Sign / symptoms of *vyakta garbhā or after conspicuousness of body parts of embryo*)

सद्योर्गृहीत गर्भ के लक्षणों के वर्णन के उपरान्त महर्षि चरक एवं सुश्रुत ने गर्भिणी के लक्षणों का वर्णन किया है, जिसका स्पष्ट अर्थ सद्योर्गृहीत गर्भ की स्थिति के बाद के लक्षणों का द्योतक हो जाता है। महर्षि चरक ने इन लक्षणों का वर्णन दौहद-ज्ञान के लिए एवं उपचार आदि की सुविधा के लिए ही किया है^३। टीकाकार चक्रपाणि ने इस काल का प्रारम्भ तृतीय मास से माना है^४। टीकाकार डह्लण ने उत्तरकालीन गर्भ के लक्षण लिखकर सम्भवतः व्यक्तार्थ की स्थिति का ही निर्देश किया है^५। अष्टाङ्गसंहकार ने व्यक्तार्थ के लक्षण लिखकर ही वर्णन किया है। टीकाकार इन्दु ने व्यक्तार्थ की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जो गर्भ स्फुटित हो, परन्तु अति सम्पूर्ण न हो, ऐसी गर्भवती के लक्षण व्यक्तार्थ के लक्षण हैं^६।

आचार्य द्वारा वर्णन निम्न है :-

तद्यथा - आर्तवादर्शनमास्यसंस्त्रवणमनाभिलाषच्छर्दिरोचकोऽलकामता च विशेषण श्रद्धाप्रणयानमुच्चा-
वचेषु भावेषु गुरुनात्रत्वं चक्षुषोन्मत्तिः स्तनयोः स्तन्यमाधयोः स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्यमन्यर्थं श्वयथुः
पादयोरोषलेभराज्युद्गमो योन्याश्चालत्वमिति गर्भे पर्यागते रूपाणि भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ४/१६)

स्तनयोः कृष्णामुखता रोमाज्युद्गमस्तथा। अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः संमील्यन्ते विशेषतः ॥

अलकामनश्छर्दयति गन्धादुद्विजते शुभ्रात्। प्रेसकः सदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ॥ (सु० सं० शा० ३/१४-१५)

क्रमेण तु व्यक्तार्थायाः कुक्षिमात्रगौरवं क्षामनेत्रवस्त्रताक्षिरोमसंतुलनं निद्रा जुग्मपणं मूर्च्छा छर्दिरोचः-
पादशोफोऽन्तेऽभिलाषस्तेषु तेषु चोच्चावचेषु भावेष्विति ॥ १॥

१. शुक्रशीतलयेयोनेस्त्रावोऽथ भ्रमोद्भवः। सञ्चिपसादः पिपासा च ग्लानिः स्फूर्तिर्भ्यो भवेत् ॥ (शा० प्र० पूर्व० ३/४२)
२. तस्या गर्भोपपत्तेर्दौहदस्य च विज्ञानार्थं लिङ्गानि समासेनोपदेश्यामः। उपवासार्थं हस्य ज्ञानं च लिङ्गतः तस्मादित्ये लिङ्गोपदेशः ॥ (च० सं० शा० ४/१६)
३. तृतीयमासमुक्तानि तु दौहदस्य च लिङ्गानि भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ४/१६ की चक्र० टी०)
४. उत्तरकालीनं गृहीतार्थाया लक्षणमाह ॥ (सु० सं० शा० ३/१४-१५ की डह्लण० टी०)
५. व्यक्तार्थाया लिङ्गम्, व्यक्तः स्फुटो नातिसम्पूर्णं गर्भो यस्याः। (अ० सं० शा० २/९ की इन्दु टी०)

पीनकपोलपयोधरता कृष्णौष्ठ चूचुकत्वं च ॥ ११॥

यथा यथा च गर्भो वृद्धिमाप्नोति तथा तथा भाराहारसापचाराच्च स्त्रिया बलक्षयः ॥ ५९॥

(अ० सं० शा० २/९, ११ एवं ५९)

तत्र व्यक्तस्य लक्षणम् ॥

क्षामता गरिमा कुक्षेर्मुच्छर्च्छर्दिरोचकः। जुग्मा प्रसेकः सदनं रोमाज्यः प्रकाशनम् ॥

अमलेष्टता स्नौनी पीनौ सस्तन्यौ कृष्णचूचुकौ। पादशोफो विदाहोऽन्ये श्रद्धाश्च विविधात्मिकाः ॥

(अ० ह० शा० १/५० से ५२)

आर्तवादर्शनं, आस्य-संस्त्रवण या मुख से बार बार साव होना, अन्न की अनिच्छा, छर्दि, अरोचक, अम्लकामता या अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा, उच्च एवं नीच भावों की बार बार आकांक्षा (आहार, विहार में कभी उच्च या उत्तम दस्तुओं में कभी नीच या निम्न गुण वाली वस्तुओं में आसक्ति), शरीर का भारीपन, अँगुलियों में ग्लानि या भारीपन, स्तनों में स्तन्य की उत्पत्ति, ओंछों एवं स्तनमण्डलों में अत्यधिक कालापन, पैरों में ईर्ष्य शोथ, रोमाज की उत्पत्ति तथा योनि का चाटालत्व (विवृतत्व) आदि सभी लक्षण गर्भ की प्राप्ति के बाद हो जाते हैं।

महर्षि सुश्रुत ने गर्भिणी के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्तनों के मुख में कालापन तथा रोमाज की उत्पत्ति हो जाती है, स्त्री विशेषकर ओंछों की पलकें बार बार बन्द करती है। वह बिना कारण ही वमन करती है, शुभ गर्भों से भी उद्विग्न होती है तथा प्रसेक (मुख से थूक आना) एवं शकावट ये गर्भिणी स्त्री के लक्षण हैं।

अष्टाङ्गसंहकार के मतानुसार व्यक्तार्थ में क्रमशः कुक्षि का भारीपन, नेत्र एवं स्वर की क्षीणता (नेत्र का भीतर धँस जाना), अक्षिरोमों का संतुलन अर्थात् अस्ताव्यस्ता, निद्रा, जुग्मा, मूर्च्छा, छर्दि, अरुचि, पादशोफ, अम्लाकांक्षा तथा उच्च एवं नीच भावों की (उत्तम या हीन आहार विहार आदि की) आकांक्षा आदि लक्षण होते हैं। पादभेद में अक्षिरोम के स्थान में योनिरोम शब्द का प्रयोग मिलता है^१। टीकाकार इन्दु ने कुक्षि के साथ ही गात्र के भी क्रमशः गौरव का वर्णन किया है एवं संतुलन का अर्थ व्यालोलता किया है^२, जिससे अस्ताव्यस्ता के स्थान में स्फुरण अर्थ हो जाता है।

उसके कपोल एवं स्तन पीन (मांसल) तथा ओष्ठ एवं चूचुक कृष्ण हो जाते हैं।

जैसे जैसे गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे वैसे गर्भ के भार को वहन करने एवं गर्भ के द्वारा आहार रस के ले लिए जाने से स्त्री का बल क्षीण होता है।

अष्टाङ्गसंहकार ने भी अष्टांगसंग्रह के सदृश ही गर्भ की व्यक्तवस्था के निम्न लक्षण लिखे हैं:- शरीर की कृशता, कुक्षि का भारीपन, मूर्च्छा, छर्दि, अरोचक, जुग्मा, प्रसेक, शकावट, रोमाज की उत्पत्ति, अम्लाकांक्षा, स्तनों की पुष्टता तथा स्तन्योत्पत्ति, चूचुक का कृष्ण होना, पैरों में शोफ, अन्न का विदाह तथा अनेकों प्रकार की इच्छाएँ होना आदि। अन्य लोग अन्न का विदाह न लेकर शरीर का विदाह वर्णन करते हैं^३।

आचार्य भावमिश्र जी ने भी शब्दभेद से महर्षि सुश्रुत के सदृश ही वर्णन दिया है^४।

१. चाटालत्व विवृतम् ॥ (च० सं० शा० ४/१६ की चक्र० टी०)
२. क्षामनेत्रवस्त्रता योनिरोमसंतुलनम् ॥ (अ० सं० शा० २/९ का इन्दुटीका पुस्तक में पादभेद १)
३. क्रमोपैव कुक्षिगात्रादि गौरवादि लक्षणम्, क्रमोपैति यथा यथा प्रवर्द्धते तथा तथा कुक्षि गौरवादयो भवन्ति योनिरोमों वा संतुलनम् व्यालोलता ॥ (अ० सं० शा० २/९ की इन्दु टी०)
४. विदाहोऽन्ये इति अन्ये आचार्या विदाहो देहे भवतीत्याहुः ॥ (अ० ह० शा० १/५२ की अरुण० टी०)
५. स्तनयोर्मुखाकांक्षार्थं स्याद्रोमज्युद्गमस्तथा। अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः संमील्यन्ते विशेषतः ॥

छर्दिरोचस्यमुक्त्वापि गन्धादुद्विजते शुभ्रात्। प्रसेकः सदनं चैव गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ॥ (शा० प्र० पूर्व० ३/४३, ४४)

After describing the features of *sadyograhita garbhā* Caraka and Sūśruta have mentioned the word “*garbhīṇā līṅgā*” or the signs/symptoms of a pregnant woman. Caraka has clarified that the description is being given for recognition and management of *dohyā*. Cakrapāṇi has included third month onwards period under this category. Vāgbhata I has used the term *vyākṛta-garbhā* to which Hindu has explained that these are the signs / symptoms of a pregnant woman who possesses the embryo of conspicuous but under developed body parts.

The signs / symptoms are as follows : amenorrhoea, excessive salivation, dislike for food, vomiting, anorexia, craving for sour substances, alternate desires of high or low articles (the eatables of high or low qualities), heaviness of body, languor of eyes, milk secretion in breasts, blackening of lips and areola, slight edema of feet, development of *romarājī* (linea nigra) and dilatation of vagina are the features mentioned by Caraka.

Sūśruta and Bhāvanīra besides mentioning blackening of areola and development of linea nigra have included repeated blinking of eye lids, vomiting without apparent cause, aversion from good smells, salivation and tiredness etc.

Vāgbhata I has written heaviness of abdomen, depression of voice and eyes, disordered eye-lashes or quivering of eye lashes or pubic hair (Indu), sleepiness, yawning, swooning, vomiting, anorexia, edema of feet, desire for sour or high or low articles etc. Her cheeks and breasts become corpulent and lips and nipples become black. Increase in weight of embryo causes diversion of her nutrients thus energy also decreases.

Vāgbhata II has given the signs/symptoms described by Caraka and Vāgbhata I with omission of a few and addition of emaciation, indigestion, burning sensation of whole body and expression of various desires in the list.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि सभी आचार्यों ने सामान्यतः दूसरे मास से चौथे या पाँचवें मास में ही उपास्थित होने वाले लक्षणों का वर्णन किया है। महर्षि चरक द्वारा वर्णित अनांतव को अन्य आचार्यों ने सद्योग्रहित-गर्भा के लक्षणों के अन्तर्गत आर्तव-अननुबन्ध शब्द से लिखा है जो अधिक युक्तिसंगत है। वाग्भट द्वारा शरीर की कुशला का वर्णन सम्भवतः दूसरे मास की स्थिति का है क्योंकि इस मास में स्त्री का भार कुछ घटता है। प्रसेक, छदि आदि लक्षण सामान्यतः तीसरे मास तक समाप्त हो जाते हैं। सभी आचार्यों ने रोमराजी की उत्पत्ति का वर्णन दिया है, वाग्भट ने इसकी उत्पत्ति का कारण रक्त की स्थिति एवं टीकाकार इन्द्र ने इसका स्थान नाभि के नीचे बताया है। वास्तव में गर्भावस्था में किसी भी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु चौथे से छठवें महीने में या उसके बाद गर्भवती स्त्रियों की नाभि के नीचे रजक द्रव्यों के अधिक एकत्र हो जाने के कारण एक रेखा लीनिया निगर (श्यामागजी) बनती है, सम्भवतः आचार्यों ने इसे ही रोमराजी वर्णित किया है। यहाँ में शोफ एवं मूर्च्छा ये दोनों लक्षण सामान्यतया देखने को नहीं मिलते।

१. (अ) स्थिते तु रक्ते रोमराजी प्रादुर्भवति । (अ० सं० शा० २/१०)

(आ) तस्मिन्नेव रक्ते स्थिते कोष्ठ एवावच्छेदं विद्या नाभेयो रोमराजिः प्रादुर्भवति ॥ (अ० सं० शा० २/१० को इन्द्र टी०)

२. मैत्र्युर्जलं औवं औम्पेटेद्विष (हार्णव एव विडव) (पृष्ठ २२)

३. वर सम्भव है कि कालचक्र के कारण किसी प्रकार “श्यामागजी” शब्द के स्थान में “रोमराजी” शब्द आ गया हो एवं बाद में मुद्रित पुस्तकों में वह यूं ही चलता रहा। स्थिति के आधार पर “श्यामागजी” शब्द अधिक युक्तिसंगत है।

ऐसा हो सकता है कि आचार्यों ने गर्भावस्था के अन्तिम मासों में भार के कारण उत्पन्न ईश्वर पादशोक का ही वर्णन किया हो। गर्भावस्था में कभी कभी विशेषकर दीर्घकालीन उत्तान-शयन में रक्तचाप अचानक ही घट जाता है एवं स्त्री को बड़बड़ाहट, स्वेदानुभूति आदि लक्षण होने लगते हैं जिसमें यद्यपि स्त्री पूर्णरूपेण मूर्छित तो नहीं होती परन्तु मूर्च्छा सी आँत लगती है^१ जो अपने आप ही स्थिति-परिवर्तन में डीक हो जाती है, सम्भवतः इसी स्थिति को आचार्यों ने मूर्च्छा शब्द से वर्णित किया हो।

Above description seems to be signs/symptoms of pregnancy from second to fifth month. Amenorrhoea described by Caraka has been incorporated by others under *sadyograhita garbhā* which is more logical. Slight decrease in weight during second month of pregnancy has probably been indicated by Vāgbhata as emaciation. Nausea, vomiting etc. disappear by third month. The development of *romarājī* (line of hair) below umbilicus due to accumulation of *rakta* is difficult to explain, since no extra hair grow during pregnancy. Probably linea nigra developing between 4th to 6th month has been referred as *romarājī*. Edema and syncope are not physiological, however, slight edema during late pregnancy and syncope attacks due to transitory hypotension in prolonged supine or erect position might have been referred as normal signs.

(इ) गर्भिणी के मासानुमासिक लक्षण (Signs/symptoms during different gestational periods)

महर्षि चरक एवं काश्यप ने मासानुमासिक गर्भ-वृद्धि के साथ होने वाले चतुर्थ से सप्तम मास में गर्भिणी के परिवर्तनों का भी उल्लेख किया है जो निम्न है।

Caraka and Kāśyapa have described following signs/symptoms of woman alongwith the fetal development from fourth to seventh month of gestational period.

(१) चतुर्थ मास में गर्भिणी का स्वरूप (Signs/symptoms in fourth month)

तस्मात्तदा गर्भिणी गुरुगात्रत्वमधिकमापद्यते विशेषेण ॥ (च० सं० शा० ४/२०)

गुरुगात्रत्वमधिकं गर्भिण्यास्तत्र जायते ॥ (का० सं० शा० २/६)

इसलिए (गर्भ में स्थिता होने के कारण) इस मास में गर्भिणी के शरीर में विशेष गुरुता आ जाती है। महर्षि काश्यप ने भी (स्थिता के कारण) गर्भिणी में अत्यधिक गुरुगात्रता का वर्णन दिया है।

Due to stability in fetus the woman feels more heaviness in the body.

(२) पञ्चम मास में गर्भिणी का स्वरूप (Signs/symptoms in fifth month)

तस्मात्तदा गर्भिणी काश्यर्मापद्यते विशेषेण । (च० सं० शा० ४/२१)

गर्भिणी पञ्चमेमासि तस्मात् काश्यर्न युज्यते ॥ (का० सं० शा० २/७)

अतः (गर्भ में मांसशोणितोपचय के कारण) गर्भिणी इस मास में विशेष कुश हो जाती है। इसका स्पष्टीकरण टीकाकार चक्रपाणि ने दिया है कि गर्भ के मांस आदि के पोषण के कारण क्षीण आहार-रस माता की धातुओं का सम्यक् पोषण नहीं करता^१।

१. त्रिसपल औवं गार्हिकर्लोत्त (जैभकॉट) (पृष्ठ ११२)

२. यतो गर्भं मांसदिपोषणेनैव क्षीण आहाररसो न मातुर्मासादि सम्यक् पोषयति ॥ (च० सं० शा० ४/२१ की चक्र० टी०)

महर्षि कारण ने भी लिखा है कि इस मास में गर्भिणी कुत्र हो जाती है ।

The woman becomes emaciated due to lack of nourishment of maternal *dhiyas* as the *rasa* is driven to nourish more and more the flesh and blood of fetus.

(३) षष्ठ मास में गर्भिणी का स्वरूप (*Signs / symptoms in sixth month*)

तस्मात्तदा गर्भिणी बलवर्णहानिमापद्यते विशेषेण ॥ (च० शा० ४/२२)

..... षष्ठ मातुः श्रोतोऽधिकः ॥ (का० सं० शा० २/७)

इसलिए (गर्भ में बल-वर्णोपचय के कारण) इस मास में गर्भिणी को बल और वर्ण की विशेष हानि होती है । महर्षि कारण ने इस मास में गर्भिणी को अधिक श्रम होने का वर्णन दिया है ।

As during this month the fetus derives relatively more strength and complexion, hence the pregnant woman suffers loss of strength and complexion, she feels more tiredness.

(४) सप्तम मास में गर्भिणी का स्वरूप (*Signs / symptoms in seventh month*)

तस्मात्तदा गर्भिणी सर्वाकारैः क्लान्ततमा भवति ॥ (च० शा० ४/२३)

सप्तेमासि तस्याच्च नित्यक्लान्ताऽत्र गर्भिणी ॥ (का० सं० शा० २/८)

अतः (गर्भ की सर्वाङ्गीण पुष्टि होने के कारण पूर्व मासों की अपेक्षा) गर्भिणी इस मास में सभी प्रकार से अर्थात् मांस, शोणित आदि सभी में क्लान्ततम या हीनतम होती है ।

महर्षि कारण ने भी इस मास में गर्भिणी के क्लान्ततम होने का वर्णन दिया है ।

As the fetus attains over all maturity in this months, the woman feels excessively exhausted or has relatively more loss of flesh and blood.

विमर्श (Comments)

यदि गर्भिणी स्त्री का आहार-विहार सामान्य हो, वह व्याधि रहित रहे, तो चतुर्थ मास के उपरान्त सप्तम मास तक उसके शारीरिक भार में काफी वृद्धि होती है अतः गर्भिणी में कुशला का प्रश्न ही नहीं उठता । यह सम्भव है कि त्वचा में रंजक द्रव्यों के एकत्रीकरण के कारण उत्पन्न धब्बे विशेषकर मुख के धब्बे ऐसा आभास प्रदान करें कि गर्भिणी के वर्ण का ह्रास हुआ है परन्तु वास्तव में ऐसा प्रत्येक गर्भिणी में नहीं देखा जाता । वर्धित होते हुए गर्भ के कारण उत्पन्न उदरगुहात्तर-भार-वृद्धि से स्त्री की कार्य-शक्ति का ह्रास होता है जिसे ही बल-ह्रास शब्द से एवं जलीय-अंश की वृद्धि के कारण उत्पन्न रक्त की द्रवता को रक्त के ह्रास शब्द से सम्भवतः आचार्यों ने वर्णित किया है ।

उपर्युक्त वर्णन का निश्चित स्पष्टीकरण कठिन है ।

If the diet and health of the pregnant woman is normal, she gains considerable weight from fourth to seventh month, hence the question of emaciation does not arise. Face-mask or deposition of pigments in other parts of the body might have been referred as loss of complexion. The decrease in the working capacity due to increased intra-abdominal pressure and reduction in hemoglobin concentration due to hydermia might have been referred as loss of strength and blood respectively.

१. सर्वाकारैरिति सर्वमांसशोणितारिज्यशून्यैः । क्लान्ततमेति हीनतमा ॥ (च० सं० शा० ४/२३ की चक्र० टी०)

(ई) गर्भ के लिङ्ग-द्योतक गर्भिणी-लक्षण (*The signs / symptoms of the mother denoting fetal sex*)

सव्याङ्गवेष्टा पुरुषाक्षिणी स्त्री स्त्रीस्वप्नपानाशनशीलवेष्टा ।

सव्यानागर्भा न च वृत्तागर्भा सव्यप्रदुग्धा स्त्रियमेव सूते ॥

पुत्रं ततो लिङ्गविवर्धयेण व्यामिश्रलिङ्गा प्रकृतिं तृतीयाम् ॥ (च० सं० शा० २/२४, २५)

तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक् पयोदर्शनं भवति, दक्षिणकुक्षिमत्वं च, पूर्व च दक्षिणं सक्षयुक्तर्षी, बाहुलाच्च पुंनमधेयेषु द्रव्येषु दौर्दमभीष्टयावति, स्वप्नेषु चोपलभते पद्यान्तलकुमुदाघातकादीनि पुंनानाम्येव, प्रमत्तपुखवर्णा च भवति, तां ब्रूयात् पुत्रमियं जनयिष्यतीति; तद्विषये कन्याम; यस्याः पार्श्वद्वयमवनतं परस्ताजिगन्तमुदरं प्रागभिहितलक्षणं च तस्या नपुंसकमिति विद्यात् ॥ (सु० सं० शा० ३/३४)

तत्र या दक्षिणं पादं पूर्वमभिहरति दक्षिणश्च यस्या बाहुर्बलवंस्तेन च चेष्टते तन्तने च प्राक् पयो दृश्यतेऽन्यत्रतलकुक्षिपरिमण्डलगर्भा पुत्रादर्शनस्यार्शनपुत्रन्दौर्दमिभिरता पुत्रामधेयांश्च स्वप्नान् पश्यति प्रमत्तपुखवर्णा तीक्ष्णशृङ्खल रोमराशिः पुरुषान्तीभिलाषिणी च सा पुत्रं प्रसूते तद्विषयं कन्यां सङ्कोरे च नपुंसकम् । प्रजनकाले नास्ती यलिङ्गमङ्ग बाह्यद्रव्यं वा परामृशति तलिङ्गमस्या गर्भमादिशेत् ॥ (अ० सं० शा० २/३६)

प्राग्दक्षिणस्तनस्या पूर्व तत्पार्श्ववेष्टिनी ॥ ६९ ॥

पुत्रागर्भदौर्दमप्रसूता पुंस्यनदर्शिनी । उन्नते दक्षिणे कुक्षौ गर्भे च परिमण्डले ॥ ७० ॥

पुत्रं सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति नसङ्गतिम् । नृत्यवादित्रगायध्वगम्यमात्यप्रिया च या ॥ ७१ ॥

क्लतीव तत्सङ्कोरे, तत्र मध्यं कुक्षेः समुन्नतम् ॥ ७२ ॥ (अ० ह० शा० १)

जो स्त्री सभी चेष्टाओं वाम भाग से करती है, पुरुष की आकांक्षा (मैथुन के लिए) रखती है, जो स्वप्न में स्त्रीलिंग पदार्थों को ही देखती है, स्त्रीलिंग (नामधारी) खाद्य तथा पेय पदार्थों की इच्छा रखती है, शीत एवं चैष्टा (हान-भाव तथा आचार आदि) स्त्रियों की तरह करती है, जिसका गर्भ वाम भाग में स्थित हो (कुक्षि के वाम भाग में), जो गोलकृति न हो (गर्भाशय की आकृति कुछ लम्बाकार हो) तथा जिसके वाम स्तन में प्रथम स्तन्य की उत्पत्ति हो तो वह कन्या का ही प्रसव करती है । इसके विपरीत लक्षण होने पर पुत्र तथा मिश्रित लक्षण होने पर नपुंसक होता है ।

महर्षि सुश्रुत ने भी वर्णन किया है कि जिस (गर्भिणी) के दक्षिण स्तन में दूध पहिले दिखई दे, जिसकी दाहिनी ओर की कुक्षि भारी हो, जो दाहिने पैर को पहिले उठाकर चलती हो, जिसका दौर्दम अधिकतर पुष्टिग नाम वाले द्रव्यों में हो; स्वप्न में पद्म, उत्पल, कुमुद, आभ्रातक आदि पदार्थों को देखती हो, जिसका मुख-वर्ण प्रसन्न अर्थात् सुन्दर हो तो उसे कहना चाहिए कि वह पुत्र ही उत्पन्न करेगी । इसके विपरीत जिसमें लक्षण हों वह कन्या उत्पन्न करेगी । जिस स्त्री के (उदर के) दोनों पार्श्व अवनत हों, उदर आगे की ओर निकला हुआ हो और पूर्वोक्त (दोनों प्रकार के) लक्षण हों उसका गर्भ नपुंसक समझना चाहिए । टीकाकार डह्लण ने रोमराजी का ऊर्ध्व होना भी पुत्रोत्पत्ति सूचक लक्षण माना है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि जो स्त्री दक्षिण पैर को प्रथम उठाकर चलती है, जिसकी दक्षिण बाहु बलवान है एवं उसी से कार्य करती है, दक्षिण स्तन में ही प्रथम स्तन्य की उत्पत्ति होती है, दक्षिण ओर की ही कुक्षि अति उन्नत हो एवं गर्भ (गर्भाशय) गोलकार हो, लम्बाकृति न हो, दौर्दम के समय पुष्टिग वाले पदार्थों के ही दर्शन, स्पर्शन एवं प्रश्न में आकांक्षा हो, मुख का वर्ण प्रसन्न हो, बुध्दिशाल हो, रोमराजी ऊर्ध्व की ओर हो, पुरुष की अतिजापा (मैथुन) न करने ज्ञाती हो, वह पुत्र की ही उत्पत्ति करती है । इसके विपरीत लक्षण होने पर कन्या एवं मिश्रित लक्षण होने पर नपुंसक की उत्पत्ति होती है । प्रश्न करने पर स्त्री जिस लिंग-नामधारक अंग को या बाह्य-द्रव्य को स्पर्श करती है वह उस लिंग के ही गर्भ जाती होती है ।

१. प्रसन्नपुखवर्णा चेत्यत्र चकाराद्दौर्दमोभिलाषिणी ग्राह्याणि ॥ (सु० सं० ३/३४ की डह्ल० टी०)

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी यही लिखा है कि जिसके दक्षिण स्तन में महिला दुग्धोत्पत्ति हो, दक्षिण अंगों से चेष्टा में प्रथमतः हो, दौहद के बारे में प्रश्न करने पर पुत्राग पदार्थ आकांक्षिणी हो, स्वप्न में पुत्रिणा हो पदार्थ देखे, कुक्षि का दाहिना भाग उन्नत हो एवं गर्भ गोलकृति हो तो वह पुत्र को जन्म देती है अन्यथा विपरीत लक्षण होने पर कन्या का प्रसव होता है। साथ ही जो नकाराक्षिणी हो; नृत्य, वादन, गायन, गन्ध एवं मालाओं आदि में रसि हो वह भी कन्या ही प्रसवित करती है। दोनों प्रकार के मिश्र लक्षण होने पर तथा कुक्षि का मध्यभाग उन्नत होने पर न्युनक का प्रसव होता है।

महर्षि कारक ने लक्षणाध्याय में योनि की आकृति वर्णित करते हुए लिखा है कि मध्य में निविड़ योनि कन्या-जन्म के लिए तथा उन्नत, समणीय एवं मोसल योनि पुत्र-जन्म के लिए होती है (ये लक्षण सामान्य स्त्री की योनि के हैं न कि गर्भिणी स्त्री के)। कुक्षि के दक्षिण भाग के उन्नत होने से पुत्र एवं बाय भाग के उन्नत होने से पुत्री के जन्म का भी उल्लेख है^१।

महर्षि भेल^२ एवं भावमिश्र^३ ने भी उपर्युक्त वर्णन-सदृश ही केवल शब्दमात्र के अन्तर से वर्णन दिया है।

Caraka opines that the woman whose left body parts are more active, has more sexual desire, dreams or wants to eat, use or have association of articles bearing feminine names, possesses feminine habits and behaviour, whose fetus (uterus) occupies more left situation in the abdomen and is not round in shape and in whom the milk secretion appears first in left breast will deliver a female child. The lady having opposite characters will have a male while mixture a hermaphrodite.

Susruta has mentioned that the pregnant woman in whom milk secretion appears first in right breast, whose right lateral portion of abdomen is heavy, who walks lifting her right leg first, who desires (to see, touch, eat, live with) the articles having masculine names, who dreams of substances possessing masculine names like *padma, upala, kumuda* and *amrataka* etc., whose face is bright and *romarājī* has upward direction will deliver a male child. Opposite to this will have a female. Whose abdomen is depressed on both sides and projects forward and has above mentioned mixed characters will deliver a hermaphrodite. Vāgbhata I corroborating the ideas of Susruta except dreams etc. adds that whose right lateral abdomen is more protuberant and fetus (uterus) is rounded in shape, has better

१. योनिः , मध्यानिविडा कन्याप्रजननाय, उन्नता समणीया मोसला पुत्रजन्मे । कुक्षी दक्षिणोन्नतौ पुत्रजन्मे, वामोन्नतौ विपरीतौ ॥ (का० सं० सू० २/८६)

२. इह खलु (ग)भो (व)स्थिता(दु)स्था(त्वापि)रमयतमुदरं भवति । मध्ये नार्यामन्तर्तायां (वामे) स्युज्जमलसंस्थित-सं समाम् वृत्तमचिच्छदं, पुरुषेऽन्ताति (दक्षिण) वृत्तमुन्नतं, क्लीवेऽन्ताति मध्यमुन्नतमुपयोगोन्तर्तायोदोर्णि(नी)चो(वो)दरं भवति (मध्य निम्न) । मातुलद(रे)स्त्री(वामे), दक्षिणे पुमान्मध्ये न्युसुकम् । वाममक्षि ह्रस्वति नार्यामन्तर्तायां, (पुरुषे)दक्षिणमुषे न्युसुके । सत्यं पादं पूर्व प्रक्रामति सत्येन वाक्षणा भुवा च पूर्व प्रतिफुल्लते चेद्वते (न च), सर्वो(ब्धे) (ग) पाश्चात् प्रायः शंसते, स्त्रीसंज्ञानेषु च प्रायसी दौहदं कुलते नार्यामन्तर्तायाय, विपयधे ततः पुरुषं बिभर्षीति विद्यात् ॥ (धे० सं० शा० ५/७३)

३. दक्षिणाक्षिमहत्त्वं स्यात् प्राक्खोरं दक्षिणे स्थने । दक्षिणोरः सुपुष्टः स्यात्समप्रमुखवर्णता ॥ ४६ ॥
पुत्रागम्येद्रव्येषु स्वनेव्यपि मनोरथः । आप्रादिफलमानोति स्वनेषु कमलादि च ॥ ४७ ॥
कन्या । पुत्रागम्यं लिङ्गानि विपरीतानि चेक्षते ॥ ४८ ॥
न्युसुकं । उन्नते भवतः पाश्चै पुरस्तादुदरं महत् ॥ ४९ ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३)

appetite and lack of sexual desire will have a male, opposite to this a female and in mixture the hermaphrodite. On being questioned to the articles of what-so-ever gender she names or touches, will have a child of the same sex.

Vāgbhata II has given similar description except that he says the woman having more sexual desire and interest in dance, instruments, songs, scents and garlands etc. will have a female child. Whose abdomen is more protuberant in center and has mixed signs will have a hermaphrodite.

Kāśyapa agreeing with the situation of fetus according to sex says that if *yoni* (vulva) of the woman (non-pregnant) is thick in centre, she will give birth to a female, however if *yoni* is beautiful, protuberant and fatty then she will give birth to male.

Bhela and Bhāvanāśira etc. have given similar description.

विमर्श (Comments)

गर्भ के लिङ्ग के अथार पर पुरुष (पैसुन) एवं भोजनादि अन्य विविध आकांक्षाओं का स्पष्टीकरण कठिन है। दक्षिण या वाम-कुक्षि-स्थिति प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्ध है।

It is difficult to give probable explanation for sexual desire or longings etc. depending upon fetal sex, however, abdominal situation of uterus specially in late pregnancy does indicate the sex of the fetus.

(उ) युग्म गर्भ में गर्भिणी के शारीरिक लक्षण (Signs in twin pregnancy)

यस्या मध्ये निम्नं द्रोणीभूतमुदरं सा युग्मं प्रसूयत इति । (सु० सं० शा० ३/३४)
यमो पाश्चाद्योत्रामा कुक्षौ द्रोण्यामिव स्थिते ॥ (अ० ह० शा० १/७२)

जिस स्त्री का उदर मध्य में द्रोणी के सदृश निम्न होता है वह युग्म बच्चों को जन्म देती है। टीकाकार इल्लहान ने रोमराजी का निम्न होना भी युग्म गर्भ का एक लक्षण माना है^३।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि यमल-गर्भ की स्थिति में कुक्षि दोनों पार्श्व से उन्नत, द्रोणिसदृश मध्य में निम्न होती है।

Whose abdomen is elevated on both the sides and depressed in centre just like a trough will deliver twins is the opinion of Susruta and Vāgbhata II.

Dalhana says that in twin pregnancy *romarājī* has downward direction.

गर्भिणी में होने वाले स्तन-परिवर्तनों का कारण (Cause of breast changes during pregnancy)

शेषं चोर्ध्वतरमागतं पयोधरावभिप्रतिपद्यते, तस्माद् गर्भिण्यः पीनोन्नतपयोधरा भवन्ति ॥

(सु० सं० शा० ४/२४)

जरायुशेषं चोर्ध्वमसृक् प्रतिपद्यते । तस्मात्पीनकोलपयोधराता कृष्णौष्णचूचुकत्वं च ॥

(अ० सं० शा० २/१९)

१. गर्भिणी-परीक्षा-काल में प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव ।

२. रोमराजी भवेन्निरामा यस्याः सा सूयते यमौ ॥ (सु० सं० शा० ३/३४ की इल्ल० टी०)

शेष रक्त (अपरा निर्माण के बाद बचा हुआ अर्धरक्त) और ऊपर आकर स्तनों को प्राप्त होता है, जिसके कारण गर्भाणी के स्तन स्थूल या पुष्ट एवं उन्नत हो जाते हैं। टीकाकार डल्हण ने स्तनों की पीनोन्नता के साथ ही कपोलों की स्वस्थता एवं ओष्ठ तथा चूचुक की कृष्णता का भी यही कारण माना है^१।

महर्षि वाग्भट ने भी यही लिखा है कि जरायु (बच्चे) से बचा हुआ रक्त ऊपर की ओर पहुँच जाता है, जिसके कारण (गर्भाणी के) स्तन एवं कपोलों में स्थूलता तथा ओष्ठ एवं चूचुक में कृष्णता आ जाती है।

आचार्य भाविमिश्र का भी यही मत है^१।

Leftover *rakta* (the *āraṭa* left over after placenta formation) goes upwards, reaches breasts and makes them heavy and erect. This very *rakta* is responsible for heaviness of cheeks and blackening of areola and lips.

विमर्श (Comments)

बच्चे हुए अर्धरक्त के द्वारा स्तन-वृद्धि आदि का स्पष्टीकरण पूर्व-वर्णित (पृष्ठ ४७) है।

Development of breasts etc. by leftover *āraṭa* has been discussed earlier (page 49).

दौहद (Dauhrda)

गर्भ एवं स्वयं का हृदय इस प्रकार दो हृदय वाली होने के कारण स्त्री दौहदिनी कहलाती है। इस काल की इच्छाओं आदि का विसृत वर्णन संहिताओं में मिलता है।

महर्षि भेल ने सारन्य के द्वारा गर्भज दोहद की परीक्षा करने का निर्देश दिया है^१।

The woman possessing two hearts (one of her own and other of the fetus) is called *dauhrdini*. The period of *dohitda* and specific longings during this period have been described elaborately in *āyurvedika* classics. Bhela has advised to examine *dauhrda* of fetus by congenial diet.

(अ) दौहद-काल (Period of dauhrda)

महर्षि सुश्रुत ने दौहद की उत्पत्ति का काल चतुर्थ मास वर्णन किया है^१।

महर्षि चरक, अष्टांगसंग्रहकार एवं अष्टांगहृदयकार किस्सी ने भी दौहद का निश्चित काल स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं लिखा। विभिन्न संहिताओं में मासानुसारिक गर्भवृद्धि के वर्णन के अनन्तर्गत ही दौहद का उल्लेख आता है अतः जिस मास के गर्भ की वृद्धि के वर्णन से सम्बन्धित दौहद का वर्णन है उस मास को ही दौहद की उत्पत्ति का काल मानना चाहिए। इस आधार पर महर्षि चरक एवं अष्टांगसंग्रहकार ने तीसरे मास तथा अष्टांगहृदयकार ने दूसरे मास में दौहद की उत्पत्ति मानी है। अष्टांगसंग्रहकार ने अन्य विद्वानों का मत उद्धृत किया है कि तीन पक्ष (गर्भाधारण होने के तीन पक्ष) से चार मास की समाप्ति या चौथवें मास के प्रारम्भ होने तक दौहद काल होता है^१।

१. तस्मात् पीनपयोधकपोलता कृष्णचूचुकत्तच्छ ॥ (सु० सं० शा० ४/२४ को डल्ह० टी०; सी० के० सेन कलकत्ता प्रकाशन)
२. शेषं चोर्ध्वतरमागतं पयोधरी याति, तस्माद्गर्भपयः पीवरपयोधरा भवन्ति ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/२०६)
३. सातन्यं गर्भेण (भजे) दौहदम् ॥ (भे० सं० वि० ४/४)
४. तस्माद् गर्भशुद्धये मास्यमीभ्रप्रायनिन्द्रियाधैषु करोति । (सु० सं० शा० ३/१८)
५. अन्ये तु पक्षत्रयत्रयभृत्यपञ्चमन्मासाद्दौहदकालमाहुः । (अ० सं० शा० २/१८)

महर्षि हारीत^१ ने तृतीय एवं आचार्य भाविमिश्र ने स्पष्टतः चतुर्थ^२ मास में दौहद की उत्पत्ति मानी है।

आधुनिक विज्ञान के अन्वेषणों से यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में ही मानव भ्रूण का एक कोष्ठ्रीय हृदय अपना स्पन्दन प्रारम्भ कर देता है अतः अष्टांगसंग्रहकार द्वारा तीन पक्ष या ६ सप्ताह में द्विहृदय गर्भाणी का वर्णन सहायनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री द्वारा गर्भस्पन्दनानुभूति के काल में भेद होने के कारण आचार्यों ने भिन्न भिन्न दौहद उत्पत्ति-काल वर्णित किया है।

Sūśruta and Bhāvanīśra have mentioned its period as fourth and Hārīta as third month of pregnancy. Others have not mentioned this period separately but have referred it in the description of fetal development, accordingly third month has been mentioned by Caraka and Vāgbhaṭa I and second month by Vāgbhaṭa II. However, citing the opinions of others Vāgbhaṭa has referred this period from three fortnights (six weeks) of conception upto the completion of fourth or beginning of fifth month.

One chambered embryonic heart starts its first beat at the end of four weeks, thus the description of six weeks period by Vāgbhaṭa I is praiseworthy. The difference in the period by various authors is probably due to relative sensitivity of the woman for feeling of quickening.

(आ) दौहद की उत्पत्ति का कारण (Cause of dauhrda)

तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि संतिष्ठन्ते, तत्कालमेव चेतसि वेदना निबन्धं प्राप्नोति; तस्मात्तदा प्रभृति गर्भः स्पन्दते, प्रार्थयते च जन्मान्तरानुभूतं यत् किञ्चित्; तद् द्वैहृदयमावक्षते वृद्धः। मातुर्जं चास्य हृदयं मातुहृदयेनाभिसम्बद्धं भवति रसवाहिनीभिः संवाहिनीभिः; तस्मात्तयोस्ताभिर्मिथः संस्पन्दते ॥ (च० सं० शा० ४/१५)

...., गर्भहृदयप्रत्यक्षिकाभावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो भवति; कस्मात् ? तत्स्थानत्वात्। तस्माद् गर्भशुद्धये मास्यमीभ्रप्रायनिन्द्रियाधैषु करोति। द्विहृदयं च नारी दौहदिनीमावक्षते ॥ (सु० सं० शा० ३/१८)

कर्मणा चोदितं जन्तोर्भीतिवत् पुनर्भवेत्। यथा तथा देवयोगाद् दौहदं जनयेद् हृदि ॥

(सु० सं० शा० ३/१५; सी० के० सेन कलकत्ता प्रकाशन)

तदा चास्य चेतना प्रव्यक्ता भवति। ततश्च तत्प्रभृति स्पन्दतेऽभिलाषं पञ्चोद्भियाधैषु करोति ॥ १६॥

मातुर्जं ह्यस्य हृदयं तद्रसहारिणीभिर्धर्मनीभिर्मातुहृदयेनाभिसम्बद्धं भवति। तस्मात्तयोस्ताभिः श्रद्धा सम्पद्यते। तथा च द्विहृदयं नारी दौहदिनीत्यावक्षते ॥ (अ० सं० शा० २/१६, १७)

मातुर्जं ह्यस्य हृदयं मातुश्च हृदयेन तत् ॥ सम्बद्धं ॥ (अ० ह० शा० १/५२, ५३)

गर्भ में जिस काल में इन्द्रियाँ स्थित होती हैं या अभिव्यक्त होती हैं उसी समय में गर्भ के मन में वेदना (सुख दुःखानुभूति) का सम्बन्ध होता है अर्थात् मन सुख दुःख आदि का अनुभव करने लगता है, इसीलिए उसी समय से गर्भ में स्पन्दन होता है और वह गर्भ पूर्वजन्मों में अनुभूत किए हुए विषयों की आकांक्षा करता है (जो माता के द्वारा अभिव्यक्त होती है); इसलिए यह काल वृद्ध लोगों द्वारा दौहद कहा जाता है। गर्भ का मातुर्ज (भावार्थ से उत्पन्न) अंग हृदय माता के हृदय से रस को वहन करने वाली नलिकाओं द्वारा (गर्भाभाडी द्वारा) सम्बद्धित रहता है अतः (वह गर्भ) उन रसवाहिनियों के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करता है अर्थात् माता द्वारा प्रकट की जाने वाली विशिष्ट इच्छायें वास्तव में गर्भ

१. दौहदं तथा। मासे तृतीये सम्प्राप्ते दोहदं भवति रिचयः ॥ (हा० सं० तृतीयस्थान ४४/२)
२. तस्माच्चतुर्थं दौहदिनी मता। (भा० प्र० पूर्व० ३/२१३)

की इच्छाये होती है। टीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है कि गर्भ दुःख निवारणाय एवं सुख प्राप्ति के लिए स्पन्दन करता है^१।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि गर्भ का हृदय प्रत्यक्ष होने से चेतना धातु भी अभिव्यक्त हो जाती है। क्यों? उसका स्थान होने से (अर्थात् चेतना का स्थान हृदय होने से), अतः गर्भ चतुर्थ मास में इन्द्रियों के विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) में अपनी इच्छा प्रकट करता है। दो हृदय युक्त होने से स्त्री को दौहदिनी कहते हैं। जिस प्रकार कर्म (पूर्वजन्म रस, गन्ध) से प्रेरित प्राणी का भवितव्य पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार पूर्वकर्म के अनुसार देव के योग से स्त्री को दौहद (कर्म) से प्रेरित प्राणी का भवितव्य पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार पूर्वकर्म के अनुसार देव के योग से स्त्री को दौहद उत्पन्न होता है।

अष्टांगसंग्रहकार के मतानुसार इस काल में (तृतीय मास में) इसको (गर्भिणी को) चेतना स्पष्ट होने लगती है, इसके बाद से लेकर गर्भ स्पन्दन करता है तथा पंचेन्द्रियों के विषयों की अभिलाषा करता है। गर्भ का मातृज भावोत्पन्न हृदय रसवाही धमनियों के द्वारा माता के हृदय से सम्बन्धित रहता है अतः उस गर्भ की आकांक्षाये माता को तथा माता की आकांक्षाये गर्भ को व्याप्त होती है^२। स्त्री दो हृदय वाली होने के कारण द्विहृदया कहलाती है।

अष्टांगहृदयकार ने दौहद की उत्पत्ति का कारण गर्भ के मातृज अंग हृदय का माता के हृदय से सम्बन्धित होना माना है। टीकाकार अरुणदत्त ने स्पष्टीकरण दिया है कि इसी परस्पर सम्बन्धता के कारण गर्भिणी के हृदय के सन्तप्त होने से गर्भ भी सन्तप्त होता है तथा वह दौहदनी कही जाती है क्योंकि वह दो हृदय वाली होती है। गर्भ अपनी इच्छाये गर्भिणी के द्वारा व्यक्त करता है यही कारण है कि गर्भिणी अपनी इच्छाओं के विपरीत भी इच्छाये व्यक्त करती है^३।

महर्षि हारीत ने आकांक्षित वस्तु देने का निर्देश किया है^४।

आचार्य भवमिश्र ने भी चतुर्थ मास में चेतना की अभिव्यक्ति के कारण दौहद की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

Caraka opines that when *indriyas* of the fetus become conspicuous, the *mana* gets association of *vedana* or feelings of happiness and sorrow during same period, due to this the fetus starts quivering and expresses the desires based on the experiences of previous life, that is why elder persons have called it *dauhrida*. The fetal heart formed with the maternal components is attached to the mother's heart via *rusavāhi* channels and by these channels it expresses its longings through the mother, or in other words the desires expressed belong to the fetus not to the mother. Cakrapāṇi says that the fetus quivers to get rid of the sorrows and obtain happiness.

Suśruta has said that during this period due to conspicuousness of heart *cetana* (consciousness) also becomes apparent as heart is its seat, thus in fourth month the fetus

१. तस्मादिति सुखदुःखसंज्ञाया सुखोत्पत्त्या दुःखपरिहारार्थं च स्पन्दते चलीति । (च० सं० शा० ४/१५ की चक्र० टी)
२. तेन गर्भसंस्पन्द्य माता व्याप्यते मातुश्च गर्भ इति ॥ (अ० सं० शा० २/१७ की इन्द्रु टी०)
३. ततश्च गर्भिणीहृदयेन सन्तप्तो गर्भहृदयमपि सन्तप्यते । परस्परं हृदयस्य सम्बद्धत्वात् । अत एव च गर्भिणी द्विहृदया दौहदनीरुच्यते । अत एव च परापरतद्द्वयत्वात्तत्काले स्वस्वभावोचितमभिलाषां विहाय नानाभिलाषां जायते ॥ (अ० ह० शा० १/५२, ५३ की अरुण० टी०)
४. यद्यत् काममते सा च ततद्व्याधिभयवतः ॥ (ह० सं० तृतीयस्थान ४९/५)
५. हृदयव्यक्तभावेन व्यप्यते चेतनाऽपि च ॥ २१२ ॥
- तस्माच्चतुर्थं गर्भसु नाजा वस्तुनि चाच्छति । ततो द्विहृदया यस्याज्जातो दौहदिनी मता ॥ २१३ ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३)

desires the objects (sound, touch, vision, taste and smell) of *indriyas*. The woman due to possession of two hearts is called *dauhridini*. As the future of present life depends upon the deeds of previous life, similarly longings during *dauhrida* are also on the basis of deeds of previous life and effect of fate.

Vagbhata I giving the cause of *dauhrida* as conspicuousness of *cetana* has given the description identical to Caraka. Vagbhata II and Arunadatta have corroborated Caraka while Bhāvanīśāra to Suśruta. Hārīta indicates that the woman should be provided with the desired substances.

(इ) दौहद की पूर्ति या अपूर्ति का परिणाम (The Effect of fulfilment and non-fulfilment of *dauhrida*)

तच्चैव कारणमवशेषमाणा न द्वैहृदयस्य विमानितं गर्भमिच्छन्ति कर्तुम् । विमानने ह्यस्य दृश्यते विनाशो विकृतिर्वा । समानयोगक्षेमा हि तदा भवति गर्भेण केबुचिदर्थेषु माता । तस्मात् प्रियहिताभ्यां गर्भिणीं विशेषेणोपचरितं कुशलताः ॥ १५ ॥

सा यद्यदिच्छेत्तदस्यै दद्यादप्यत्र गर्भोपघातकस्थेभ्यो भावेभ्यः ॥ १७ ॥

तीव्रायां तु खलु प्रार्थनायां काममहितमप्यस्यै हितेनोपहितं दद्यात् प्रार्थनाविनयगर्भम् । प्रार्थनासंघातगान्धि वायुः प्रकुपितोऽन्तःशरीरमनुचरन् गर्भस्यापघातमस्य विनाशं वैरूप्यं वा कुर्यात् ॥ १९ ॥

(च० सं० शा० ४/१५, १७ व १९)

दौहदविमाननात् कुब्जं कुपितं खड्गं जडं वामनं विकृताक्षमनक्षं वा नारी सुतं जनयति । तस्मात् सा यद् यदिच्छेत्ततस्यै दापयेत् । लब्धदौहदा हि वीर्यवन्तं चिरायुषं च पुत्रं जनयति ॥

इन्द्रियार्थास्तु यात् यात् सा भोक्तुमिच्छति गर्भिणी ।
गर्भावाधभयान्तांस्तान् भिषगाहृत्य दापयेत् ॥
सा प्राप्तदौहदा पुत्रं जनयेत् गुणान्वितम् ।
अलब्धदौहदा गर्भं लभेतात्सनि वा भयम् ॥
येषु येष्विन्द्रियाथेषु दौहदे वै विमानना ।

प्राजयेत् सुतस्यातिस्तिम्बिस्तिम्बिस्थेन्द्रिये ॥ (सु० सं० शा० ३/१८ से २१)

प्रार्थनायां च तीव्रायां काममहितमप्यस्यै हितोपसहितं दद्यात् ॥ १९ ॥

दौहदविमाननाद्दि वायुः प्रकुपितोऽन्तःशरीरमनुचरन् गर्भस्य विनाशं वैरूप्यं वा कुर्यात् ॥ २० ॥
लब्धदौहदा तु वीर्यवन्तं चिरायुषं च पुत्रं प्रसूते ॥ २१ ॥ (अ० सं० शा० २/१९, २०, २१)

..... तेन गर्भिण्या नेष्टं श्रद्धाविमानम् ।

देयमप्यहितं तस्यै हितोपहितमत्यक्तम् ॥ ५३ ॥

श्रद्धाविघाताद्यर्भस्य विकृतिरिष्यतिरेव वा ॥ ५४ ॥ (अ० ह० शा० १)

इसी कारण (माता के हृदय से गर्भ के सम्बन्धित होने के कारण) को ध्यान में रखते हुए दौहद का अपमान (अपूर्ति) नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ-विकृति या गर्भ-विनाश हो जाता है। माता किन्हीं-किन्हीं अर्थों में गर्भ के समान योगक्षेम वाली होती है अतः कुशल लोग विशेषकर गर्भिणी की प्रिय एवं हित पदार्थों से परिचर्या करते हैं। द्विहृदया स्त्री जिन जिन इच्छाओं को व्यक्त करती है गर्भ-विनाशक भावों को छोड़कर अन्य इच्छाओं पूर्ण करनी चाहिए।

यदि गर्भिणी गर्भ-विनाशक-भावों की ही अतितीव्र इच्छा करती है तो उन द्रव्यों को हित वस्तुओं के साथ मिलकर इच्छा-पूर्ति के लिए देना चाहिए. क्योंकि इच्छा को रोकने या पूर्ण न करने से वायु प्रकुपित होकर अन्तःशरीर में विचरण करती हुई गर्भ को व्याधियाँ, विनाश या वैरूप्य कर देती है।

टीकाकार चक्रपाणि ने प्रयोगकरण दिया है कि यदि महती आकांक्षा का विधात हुआ तो गर्भनाश एवं यदि छोटी आकांक्षा का विधात हुआ तो गर्भविकृति होती है। यदि माता के द्वारा व्यक्त गर्भ की इच्छा का हनन हुआ तो गर्भ का इच्छा से सीधा सम्बन्ध होने के कारण उस अत्यधिक सुकुमार गर्भ की वायु विकृत होकर उसका विनाश कर देती है। यदि माता की स्वयं की इच्छा का हनन हो तो माता की विकृत वायु माता एवं गर्भ के समानयोग (सुख-हेतु-योग), क्षेम (प्रत्यवाय परिहार) होने के कारण गर्भ में मानसिक विकार उत्पन्न कर अन्य विकृति उत्पन्न करती है, परन्तु कभी कभी अयोगक्षेम होने में माता के क्षुब्ध विकार हर समय गर्भ में विकार नहीं उत्पन्न करते। 'गर्भिणी में विशेष' शब्द से ऋतुकाल में भी प्रिय एवं हित परिचर्या निर्दिष्ट है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि दौहद का विमानन या उपेक्षा करने से स्त्री कुब्ज, कुणि (विकृत हस्त), खंज (विकृत पाद), जड (मन्द बुद्धि), वामन एवं विकृत आँख वाले अथवा आँख रहित पुत्र को उत्पन्न करती है, अतः वह जो जो इच्छा करे उसे देना चाहिए। दौहद के पूर्ण होने से वीर्यवान एवं चिरायु पुत्र को जन्म देती है।

गर्भिणी स्त्री इन्द्रियों के जिन जिन विषयों के उपयोग की इच्छा करे, सिकित्सक गर्भ की बाधा के पथ से उस उस पदार्थ को दिलावे। स्त्री दौहद प्राप्त होने पर गुणवान पुत्र को जन्म देती है एवं दौहद की पूर्ति न होने पर स्वयं एवं गर्भ के लिए भय (किसी विकृति का) होता है। दौहद में होने वाले जिन जिन इन्द्रियों के विषयों की उपेक्षा होती है उन उन इन्द्रियों के विकार से युक्त पुत्र का स्त्री जन्म देती है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि (गर्भिणी को) अहितकारी वस्तुओं की भी अतितीव्र कामना होने पर उन्हें हितकारी वस्तुओं के साथ मिलकर देना चाहिए। दौहद की उपेक्षा होने से वायु प्रकुपित होकर अन्तःशरीर में गति करती हुई गर्भ का विनाश या विरूपता कर देती है। दौहद की पूर्ति हो जाने पर स्त्री वीर्यवान एवं चिरायु पुत्र का जन्म देती है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि गर्भिणी स्त्री की इच्छाओं का विमानन करना यथेष्ट नहीं है। विमानन शब्द से टीकाकार अरुणदत्त ने अप्रतिरूपण अर्थ किया है। (गर्भिणी को) अहित की भी आकांक्षा होने पर उसे हित के साथ मिलकर अल्प मात्रा में देना चाहिए (एवं हित पदार्थ तो देने ही चाहिए), क्योंकि आकांक्षा के विधात से गर्भ की विकृति या च्युति हो सकती है। टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है कि दौहद की पूर्ति से वीर्यवान एवं चिरायु पुत्र को गर्भिणी जन्म देती है।

महर्षि हारीत ने दौहद की पूर्ति से रूपवान, शूर, पण्डित या विद्वान एवं शीलवान पुत्र की उत्पत्ति का वर्णन दिया है।

१. गर्भस्य विनाशो विकृतिर्वेति महति इच्छाविधातेन विनाशः, स्वल्पेन तु विकृतिः, किंवा गर्भेच्छापूर्विका मातृरिच्छा, तद्विधातेन विनाशो गर्भस्य, सा हीच्छा विहाता साहास्रसर्पबन्धनितया सुकुमारतर गर्भं वातप्रकोपादिनाशयति, या तु मातृरिच्छा विहाता, सा मातरी वातक्षोभं जनयती समानयोगक्षेमे गर्भेऽपि ममत्विकृतिजननादिकृतिं जनयति, एतदेव दृश्यति-समानयोगक्षेमा-हेतुत्वादि-योगः सुखहेतुयोगः, क्षेमः प्रत्यवायपरिहारः, एतौ, योगक्षेमी मातृगर्भिण्य समानौ भवतः। केषुचित्दृष्टव्यविवचन-दुस्तुत्यायोगक्षेमात् च क्वचिद्भवतीति दृश्यति। तेन, नावस्य मातृविकाराः शुद्धद्रव्यो गर्भं विकृतिमावहति, गर्भस्य वा मातरीति दृश्यति। गर्भगर्भविशेषणेति चचनादगर्भिण्यापि स्त्री ऋतुकाले प्रियहितोपचाराणीया ॥ (च० सं० शा० ४/१५ की चक्र० टी०)
२. यतश्चैवं श्रद्धाविमाननं अपिल्लाषाप्रतिपूरणं, नेष्टम् (अ० ह० शा० १/५३ की अरण० टी०)
३. लब्धदौहदो तु वीर्यवन्तं चिरायुषं च सुतं सूते ॥ (अ० ह० शा० १/५४ की अरण० टी०)
४. दौहदवतिष्ठ परिपूर्णैरु रूपवान् शूरः पण्डितः शीलवान्पुत्रो जायते ॥ (ह० सं० तुतीयग्रन्थान् ४/१०)

आचार्य भवामिश्र ने शब्दभेद से महर्षि सुश्रुत का अनुगमन किया है 'केवल 'खंज' के स्थान पर 'फाड' लिखा है। Caraka says that as desires of the fetus are expressed through the mother hence *daulyrda* should always be fulfilled, because the negligence or non-fulfilment can cause abnormalities or even death of the fetus. Mostly welfare of the mother, is identical to that of the fetus, thus wise persons always treat pregnant woman affectionately and with beneficial substances. What-so-ever the *daulyrdaya* woman desires, it should be fulfilled except the things likely to injure or tell-upon the fetus. However, if her desire to use the articles likely to harm the fetus is very acute, the articles should be provided with addition of beneficial substances capable of counteracting the harmful effects. Suppression of desires vitiates *vāyū*, which moving in the body of the fetus produces various diseases, abnormalities or even death. Cakrapāṇi has clarified that suppression of acute desires causes death of the fetus while that of mild ones the abnormalities. If desires of fetus expressed by the mother are suppressed then due to direct association of these desires with very delicate fetus, its *vāyū* gets vitiated and injures it. However, if mother's own desires are suppressed then vitiated *vāyū* of mother reaches the fetus, because welfare (the condition providing pleasure or satisfaction and the opposite or harmful things to be given up) of both is same, and this aggravated *vāyū* influencing *manā* (psyche) of the fetus produces various abnormalities. At certain times due to slight difference in welfare of both, the abnormalities of mother like hunger etc. do not affect the fetus. This congenial and affectionate treatment should be extended even to non pregnant woman during *prākāla*.

Suśruta has mentioned that non-fulfilment of desires produces the fetus which is hump-backed, crooked armed and legged, idiot, dwarf, dis-shaped eyed or has absence of eyes. What-so-ever she desires should be fulfilled due to fear of fetal abnormalities. Non-fulfilment can harm both mother and fetus, specially suppression of desires related to specific *indriya* produces abnormality of corresponding *indriya* of the fetus. Fulfilment of desires results in birth of child possessing high qualities and longevity.

Both Vāgbhaṭas have followed Caraka describing the subject in short, similarly Bhavamiśra has followed Suśruta substituting crooked leg with impotence.

Hārīta has mentioned that fulfilment of *daulyrda* gives birth to a very handsome, valiant, intelligent and well behaved child.

(ई) शिशु-चरित्र-प्रदर्शककारी दौहद (*Specific daulyrda denoting character of the child*)

राजसन्ध्यनि यस्या दौहदं जायते स्त्रियाः। अर्धवन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसूयते ॥
दुकूलपादकौषेयभूषणदिद्यु दौहदान्। अलङ्करीषिणं पुत्रं ललितं सा प्रसूयते ॥
आश्रमे संयतात्मानं धर्मशीलं प्रसूयते। दैवताप्रतिमायां तु प्रसूते पार्श्वोपमम् ॥

१. दौहदावस्था कुब्जं कुणि षण्डं च वामनम्। विकृतक्षमर्धं वा पुत्रं नारी प्रसूयते ॥ २१४॥

यतः स्त्री दौहदं प्राप्य वीर्यवन्तं चिरायुषम्। पुत्रं प्रसूयते तस्मात्तस्यै वाञ्छितमपेक्षत् ॥ २१५॥

इन्द्रियार्थास्तु जनयेत् साज्ज्वमनिता प्रसूयते सुतं सति तस्मिन्तस्मिन्सतिदिश्ये ॥ २१६ से २१८॥ (सुश्रुत सद्युह ही)। (पा० प्र० पूर्व० ३/२१४ से २१८)

दर्शने व्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रमुच्यते गोधामांसाशने पुत्रं सुषुप्तं धारणात्मकम् ॥
गावां मांसं तु बलिनं सर्वकलेशसहं तथा। माहिषे दौर्हदाच्छूरां रक्ताक्षं लोमसंयुतम् ॥
वराहमांसं स्वप्नलु शूरां सञ्जनयेत् सुतम् । मार्गाद् विक्रान्तजङ्गलं सदा वनचरं सुतम् ।

सुमराद् विश्रमसं नित्यभीतं च तैत्तिरात् ॥

अतोऽनुकेषु या नारी समीपेभ्यश्च दौर्हदम् । शरीराचारशीलैः सा समानं जनयिष्यति ॥
(सु० सं० शा० ३/२२ से २८)

(पूर्व वर्णित है कि महर्षि सुश्रुत ने स्पष्ट किया है कि गर्भ के पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में होने वाले भविष्य के अनुसार ही स्त्री का दौर्हद होता है उसी का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है) ।

जिस स्त्री को राजा के दर्शन का दौर्हद हो तो वह धनो, बहुल ही भग्यशाली पुत्र को जन्म देती है । दुर्कृतपट्ट (महीन कपड़े), कौशेय (रेशमी वस्त्र) एवं आपूर्णों आदि का दौर्हद होने पर वह स्त्री अलङ्कार प्रिय एवं सुन्दर; आश्रम में (आश्रमवास के लिए दौर्हद होने पर) जितोद्विज तथा धर्मशील, देवता की प्रतिमा के दर्शन में (इच्छा होने पर) गर्भदोषम में (अत्यन्त सभ्य); व्याल जाति (हिंस्र पशु) के दर्शन से ब्रूर पुत्र को जन्म देती है । गोधा-मांस खाने (का दौर्हद होने) में निद्रालु तथा धारणात्मक (हृदय की वस्तु को न निकालने वाला) या अधिक दौड़ने वाला; गोमांस में (के इच्छा बलवान तथा सर्वश्लेशसह; माहिष (धैस) मांस का दौर्हद होने पर शूर, रक्ताक्ष एवं रोमयूक्त; वराह के मांस में (इच्छा से) स्वप्नलु, वीर; मार्ग (गुणमांस) से विक्रान्त (उद्योगी), जङ्गल (वेगवान या द्रुतगतिवान्) तथा हमेशा जंगल में विचरण करने वाले; सुमर-मांस से उद्विग्न मन वाले तथा तित्तिर (के मांस की इच्छा) से डरायेक पुत्र को जन्म देती है । इनके अतिरिक्त अब तक न बतलाए हुए जिन विषयों में स्त्री दौर्हद करती है उन्हीं के अनुसार शरीर, आचार एवं शील वाले पुत्र को जन्म देती है ।

आचार्य भावमिश्र जी ने भी महर्षि सुश्रुत-सदृश ही वर्णन दिया है, केवल गोधा, गो, स्मर एवं तित्तिर के मांस का वर्णन नहीं दिया । लगभग इसी प्रकार का वर्णन महर्षि चरक एवं वाग्भट ने गर्भमेघवातकर भावों के अन्तर्गत किया है । जिसका वर्णन यथास्थान किया जायेगा ।

Suśruta and Bhāvanmīśra have given a long list of desires expressed by the mother indicative of probable characters of the child.

Daurhda or desires	Characters of the child
1. To look at king	Rich, very lucky.
2. To wear very fine silk garments and ornaments	Fond of ornaments and handsome.
	cont. ...

१. 'धावनात्मक' (पादटीका)

२. मार्गात् गुणमांसात् विक्रान्तं उद्योगिनं, जङ्गलं वेगवन्तम् । (सु० सं० शा० ३/२७ की इच्छा टी०)

३. सुमर = महाशूकर (इच्छा) या बहुत भागने वाला गुणविशेष (अमरकोष)

४. राजसदृशने यस्या हिंसाशीलं प्रमुच्यते ॥ २११ से ३०२/१ (सुश्रुत सं० सदृश ही)

रक्ताक्षं लोमसं शूरां माहिषाभिष्वदौर्हदात् ॥ ३०२ ॥

वराहमांसं स्वप्नलु शूरां सञ्जनयेत्सुतम् ।

गुणमांसं तु जङ्गलं विक्रान्तं वनचारिणम् ॥ ३०३ ॥

अतोऽनुकेषु दौर्हदं विदधाति हि । जनयिष्यति ॥ ३०४ ॥ (सुश्रुत सं० ही) (पा० प्र० पूर्व० ३)

Daurhda or desires	Characters of the child
3. To live in <i>āśrama</i> (pious place)	Capable of controlling <i>indriyas</i> and religious.
4. To look at an idol of a diety	Extremely courteous like <i>pārśada</i> .
5. To look at snake etc. wild creatures	Ferocious or ruthless.
6. To eat* meat of iguana	Sleepiness and that whose nature consists in bearing itself or does not express his desires or runner.
7. To eat* cow's meat	Mighty and with good endurance.
8. To eat buffalo's meat	Brave, red eyes and excessive body hair.
9. To eat hog's meat	Sleepy, brave or bold.
10. To eat deer's meat	Industrious, swift runner and always moves in forests.
11. To eat* meat of <i>śyāmarā*</i>	Terrified or anxious.
12. To eat* meat of partridge	Paltrous.

* Not mentioned by Bhāvanmīśra.

** Big bear by Dalhana and fast running specific deer by Amarakośa.

Besides these what-so-ever untold things are desired by the woman, the born child reflects the features, conduct and behaviour accordingly.

विमर्श (Comments)

पूर्वपृष्ठों में वर्णित दौर्हद के विषय के बारे में आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण कठिन है यद्यपि इतना तो सिद्ध हो चुका है कि गर्भिणी के शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति का गर्भ के शरीर या मन पर प्रभाव होता है । क्रियात्मक क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी गर्भिणी स्वयं कुछ ऐसी चीजों की आकांक्षा करती है, जो उसने न तो पूर्व-जीवन में कभी खाई हुई होती है और न ही प्रसव के बाद खाने की इच्छा करती है, सम्भवतः इसी प्रकार के लक्षणों को देखकर आचार्यों ने दौर्हद की कल्पना की हो । यह हो सकता है कि इच्छा पूर्ण न होने पर स्त्री के मानसिक अशांत का कुछ प्रभाव गर्भ के मानसिक विकास पर पड़े परन्तु ईन्द्रियों में विकार तथा विशिष्ट दौर्हद से विशिष्ट प्रकार के पुत्र की उत्पत्ति आदि वर्णनों का स्पष्टीकरण कठिन है ।

Abnormal longings of pregnant woman are probably source of this description. The suppression of desires may influence psychology of mother and fetus as well, however, exact scientific explanation of this entire topic is not possible.

गर्भिणी-परिचर्या (Antenatal care)

गर्भिणी का सामान्य आहार-विहार (Normal dietetics and mode of life of pregnant woman)

तस्मादहितानहारविहारान् प्रजासंपदमिच्छन्ती स्त्री विशेषेण वर्णयेत् (वर्जयेत् शु० पा०) । साव्याचारा चान्धानमुपवेशेद्विज्ञाभ्यामाहारविहारभ्यामिति ॥ (च० सं० शा० ८/२१)

गर्भिणीं प्रथमदिवसात् प्रभृति नित्यं प्रहृष्टा शुच्यलङ्कृता शुक्लवस्त्राणां प्राणिमङ्गलदेवताब्राह्मणपुराणा च भवेत् ।^१। शयनासनं मृद्वस्तराणं नालुच्यमपाश्रयोत्तमसम्बाधं च विदध्यात्, हृद्यं द्रवं मधुरप्रायं स्निग्धं दीपनीयसंस्कृतं च भोजनं भोजयेत्, सामान्यमेतदाप्रसवात् ॥ (सु० सं० शा० १०/३)

गर्भसमानयोगक्षेमा हि गर्भिणी भवति । तस्माद्विशेषतस्तं प्रियहिताभ्यां गर्भपेधातकरेभ्यो रक्षेत् ॥ (अ० सं० शा० १/५८)

आंशधार्वावनीयाश्च बाह्यान्तरपयोजयेत् ॥ ४२ ॥

उपवातः प्रियहितैर्भर्गं भृत्यंश्च गर्भयुक् । नवनीतघृतक्षीरैः सदा चैनामुपाजयेत् ॥ ४३ ॥ (अ० ह० शा० १)

सेवितान्यव्रणानि गर्भिण्या याव्यभ-.....। तानि सात्त्वानि वात्यं तस्मात्तान्युपाचारयेत् ॥

देजकालप्रिमात्राणां न च कुर्याद्व्यतिक्रमम् ॥ (का० सं० सू० १८/२४, ३५)

यानि द्रव्याणि पुण्यानि मङ्गल्यानि शुचीनि च । नवाभ्यभ्रण्डण्डानि पुत्राणामि प्रियाणि च ॥

गर्भिण्यै तान्युपहरेद्वासाभ्याभरणानि च । न स्त्री नपुंसकाख्यानि धारयेद्वा लभेत वा ॥

धृतिवर्धितसंमृष्टं मशकाद्यापवर्जितम् । ब्रह्मधैर्यैः सवादिदेवार्तिं वेश्म शस्यते ॥

(प्रातरुत्थाय) शौचान्ते गुरुदेवादीन् रता । अर्चयित्व्युद्यतं गन्धधूपार्घ्यवाजपैः ॥ (का० सं० शा० ५/१२-१५)

नित्यं स्नाता च हृष्टा च शुक्लवस्त्रधरा शुचिः । देवविप्रपा संयथा गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥ (का० सं० चि० २/१४४)

नित्यस्नाता च गुह्या च शुक्लवस्त्रधरा शुचिः ॥ १७६ ॥

देवविप्रपा संयथा गर्भिणी तु सदा भवेत् ॥ (का० सं० छि० १०)

उत्तम गुण-युक्त संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को अहित करने वाले आहार-विहारों को विशेष रूप से त्याग देना चाहिए । वह साधु या सुन्दर आचरण वाली रहकर, हितकर आहार-विहार द्वारा स्वयं (आत्म) की रक्षा करे ।

महर्षि सुश्रुत ने गर्भिणी के सामान्य आहार-विहार का निर्देश करते हुए निम्न है कि गर्भिणी प्रथम दिन से ही (गर्भावस्था के प्रथम दिन से ही) नित्यप्रति प्रसन्नचित्त, पवित्र, अलंकारों से विभूषित, श्वेत या स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाली, शान्ति-कर्म (हवन आदि), मंगल-कर्म, देवता-ब्राह्मण-गुरु की पूजा करने वाली होनी चाहिए । इसके शयन एवं बैठने का स्थान मृदु वस्त्रों से युक्त, न बहुत ऊँचा, अपाश्रय (सहारे के लिए बनाए हुए स्थान) से युक्त एवं बाधा-विरहित होना चाहिए । वह हृष्ट (मन को अच्छे लगने वाले), द्रव, विशेषकर मधुर, स्निग्ध पदार्थों का दीपनीय द्रव्यों से संस्कार कर भोजन करे । इस प्रकार प्रसवकाल तक सामान्य परिचर्या करे ।

अष्टाङ्गसंहकार ने संक्षेप में कहा है कि गर्भिणी का योग (सुखादि) तथा श्रेम (अहित परिवर्जन आदि) गर्भ के ही समान होता है, अतः इस गर्भिणी की प्रिय एवं हितकर आहार-विहार द्वारा गर्भ को नष्ट करने वाले भर्गवों से रक्षा करनी चाहिए । वृंहणार्ह व्यक्तियों के अन्तर्गत गर्भिणी का उल्लेख है^२।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि गर्भिणी स्त्री को जीवनीय गण की औषधियों का बाह्य (स्नानार्थ जल निर्माण में या अन्य प्रदोषादि के लिए) तथा अंतः (चूर्ण, फाट, हिम आदि के स्वरूप में) प्रयोग करना चाहिए, पति एवं पुरुष द्वारा प्रिय एवं हित व्यवहार गर्भधारण में सहायक होता है । इसे सदा नवनीत, घृत तथा क्षीर का प्रयोग करना चाहिए ।

१. तान्युपाजयेत् - शु० पा०

२. अ० सं० सू० २४/११

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि गर्भावस्था में जो अन्नपान गर्भिणी स्त्री सेवन करती है, वज्ज्वे को वही सात्व्य होते हैं, अतः देश, काल तथा अग्नि को मात्रा (पावन शक्ति) का ध्यान रखकर भोजन करना चाहिए, उनका व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए ।

पुनश्च गर्भिणी के वस्त्र, निवास-स्थान तथा आचार आदि का विशद वर्णन दिया है कि गर्भिणी स्त्री को पुण्यकारक, मंगलकारक, पवित्र, नवीन, अभय, अव्योढत, पुष्पेण या पुत्राभ वाले प्रिय वस्त्र एवं आभरण आदि देवे । स्त्री या नपुंसक रितों के नाम वाले द्रव्यों को गर्भिणी न धारण करे, न ही प्राप्त करे । गर्भिणी का निवास-स्थान धूप एवं पूजा किया जाने वाला, मशक आदि (कोटाणुओं) से विरहित, ब्राह्मण-वाक्य या वेदवाक्य से आबोधित तथा गायन-वादन से युक्त उचित माना जाता है । गर्भिणी को प्रातः उठकर शौचादि कर्म के अन्त में या इन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गुरु एवं देवता की आराधना में लगना रहना चाहिए तथा उदित होते हुए सूर्य की गंध, अर्घ्य एवं जल से पूजा करनी चाहिए ।

पुत्राकांक्षी गर्भिणी स्त्री नित्य स्नान करने वाली, प्रसन्नचित्त, श्वेत या स्वच्छ वस्त्रधारी, पवित्र, देवता तथा ब्राह्मण को सम्मान करने वाली तथा सौम्य आचरण वाली होनी चाहिए ।

अन्य महर्षि काश्यप ने उद्गुरुक्त श्लोक की पुनरावृत्ति की है केवल हृष्टा (प्रसन्न चित्त) के स्थान में गुह्या (शरीर पोछने वाली) शब्द तथा पुत्राकांक्षी न कह सामान्य गर्भिणी को निर्दिष्ट किया है । विभिन्न आहार-द्रव्यों की उपयोगिता के अन्तर्गत गर्भिणी को उष्ण जल-प्रयोग^३ दुग्ध एवं मांसरस-प्रयोग निर्दिष्ट किया है । दुग्ध के प्रयोग से गर्भ पुष्टि एवं दृढ़त्व प्राप्त करता है^४ । मांस गर्भावधान-कारक, गर्भ-पुष्टिकर, गर्भिणी की वायु का शामक, रस-युक्त मांस परमौषध, दुग्ध के साथ सिद्ध किया हुआ, मधुर अथवा लवण मांस-रस गर्भ-काल में प्रशस्त है^५ ।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि वैद्य गर्भिणी स्त्री को सूरण तथा गौल्य पदार्थ (अति विषम-कारक पदार्थ) रस सहित तथा सभी पथ्य एवं हितकारी वस्तुओं देवे । वर्णित विधान के अनुसार रहते हुए एवं आचरण करते हुए पाँचवें एवं आठवें महीने में मंगल-कर्म करके ब्राह्मण तथा गोत्र के लोगों को भोजन करवाना चाहिए^६ ।

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत सदृश ही गर्भिणी को प्रसन्न-चित्त, अलंकृत, पवित्र, शुक्ल-वस्त्रधारी, गुरु आदि की अर्चना करने तथा दीपनीय द्रव्यों से संस्कृत हृष्ट, स्निग्ध, मधुरप्राय, द्रव एवं लघु भोजन करने का निर्देश दिया है^७ ।

योगरत्नकर-कार ने आहार-विहारों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शान्ति तथा षष्टिक धान्य: मधुर, गोधूम, ताना का सत्व, नवनीत, घृत, क्षीर, रसला (शर्करा एवं मसाला-युक्त दही) मधु, शर्करा, पनस (कटहल), कटली (केला), धात्री

१. गुर्विणी वोष्णकं पिबेत् ॥ (का० सं० चि० २३/२५)

२. क्षीरं.....। पुष्टिर्दृढत्वं लभते च गर्भो ॥ (का० सं० क० ७/८७)

३. गर्भावधानकरं मांसमन्ते पुष्टिकरं तथा । गर्भिणीनां च नारीणां वातप्रशमनं पम् ॥ ६ ॥

.....। गर्भकाले च। मांसं परमौषधम् ॥ ७ ॥

क्षीण (२) सिद्धो मांसरसो मधुरो लवणोऽपि वा ॥ ११ ॥

.....। गर्भकाले च शस्यते ॥ १२ ॥ (का० सं० चि० २४/६, ७, ११, १२)

४. सूरणां प्रदेयानि गौल्यानि सरसानि च । पथ्ये हितानि चैतानि गुर्विणीनां सदा भिषक् ॥ ८ ॥

अशोषकं विहितमपि स्वकीयाचारेण पञ्चमासिकमष्टमासिकं वा । ब्राह्मणमङ्गलादिभिर्यत्र भोजनमपि कर्तव्यम् ॥ १० ॥

(हो० सं० तु० स्था० ४९)

५. गर्भिणी प्रथमाहः प्रहृष्टा भूषिता शुचिः । भवेच्छुक्लाभ्यारधता गुर्विप्राचीनं रा ॥

भोज्यं तु मधुरप्रायं स्निग्धं हृद्यं द्रवं लघु । संस्कृतं दीपनीयं तु नित्यमेवोपयोजयेत् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३३०, ३३१)

(आंवला), द्राक्षा, अमल तथा मधुर रस (के पदार्थ), शीतल द्रव्य, कस्तूरी, चन्दन, माला, कर्पूर का अनुलेपन (शरीर में), चाँदनी का स्नान अर्थात् चाँदनी सेवन, अभ्यंग, मृदु शय्या तथा शीतल वायु (का सेवन), संतर्पण (जन्म पदार्थ सेवन), प्रिय का आलिंगन तथा मन को प्रसन्न करने वाले अन्य विहार, प्रिय अन्न तथा पान गर्भिणी के लिए मना हितकारी होते हैं^१।

लाक्षादि तैल के बारम्बार अभ्यङ्ग से गर्भिणी स्त्री का गर्भ पृष्ठ होता है^१। गर्भिणी, विशेषकर मृत-प्रसवा या बार-बार सन्तान मर जाने वाली स्त्रियों के लिए फलप्लवत का पान लाभदायक है^१।

Caraka says that the pregnant woman desirous of producing a thorough (heathily and good looking) child should give up non-congenial diet and mode of life and protect herself by doing good conduct and using congenial diets and mode of life.

Suśruta has advised that the woman from the very first day of pregnancy should remain in high spirit, pious, decorated with ornaments, wear clean white garments and perform religious rites, do auspicious deeds and worship deity, *brāhmaṇas* and priest. Her sleeping and sitting place should be covered with soft cushion or mattress, not be very high, possess elevated upper portion for head-rest and should be perfect and very comfortable. She should use palatable, liquid, sweet and unctuous substances treated with appetizing things. This mode of life should be continued till delivery.

Vāgbhata I has said that since welfare and contraindications of mother and fetus are identical, hence the pregnant woman should use desired congenial diet and proper mode of life, avoiding factors likely to harm the fetus. The pregnant woman is fit for the use of *virihāna* (anabolic) therapy.

Vāgbhata II has advised external (for preparing water for bathing or irrigation etc.) and internal (powder, cold decoction, decoction etc.) use of *jīvanīya* group of drugs. Affection-ate and good behaviour of husband and servants helps in maintenance of pregnancy. She should always use butter, *ghṛta* and milk etc.

Kāśyapa says that what-so-ever eatables or drinkable are consumed by the pregnant woman, same become congenial to the fetus, thus diet should be taken considering place of living, time or season and digestive capacity, it should never be neglected. She should use meritorious, auspicious, pious, new and intact or unbroken garments and ornaments possessing masculine names. No article bearing feminine or common gender name should ever be used. Her appropriate abode is that which is being fumigated (with fragrant drugs), where worship are being performed, is free from insects like mosquito etc., *vedic* hymns are being

१. शातला: गडिका: मुद्रा: गोधूमा: लाजसकक: । नवीनतं पृतं क्षीरं रसाला मधु शर्करा ॥

पसं कदलं धानी द्राक्षास्तु रस्तु शीतलम् । कस्तूरी चन्दनं माला कर्पूरमनुलेपनम् ॥

चन्द्रिका स्नानमप्यङ्गो मृदुशय्या हिमनिलः । संतर्पणं प्रियारत्नेषो विहाराश्च मनोरमा ॥

प्रियकरं चाग्रपानं गर्भिणीनां हितं सदा ॥ (यो० २० क्षीरदोषचिकित्सा)

२. शा० सं० मध्म० ९/३ से ९८ ।

३. अ० सं० उ० ३९/८३; अ० ह० उ० ३४/६३ से ६९; भा० म० चि० ७०/५४ से ६९ एवं यो० २० स्त्री रोग चि० ।

recited by *brāhmaṇas* and songs and instruments are being played. The woman after leaving her bed in the morning and performing daily routine should get busy in adorning the priests and deity and worshipping the rising sun with perfumes, incense, libation and water. She should take bath daily and remain well behaved. She should use hot water, milk and meat. Milk provides nourishment and stability to the fetus; meat helps in achievement of pregnancy, provides nourishment to the fetus, suppresses *vāta* of pregnant woman, meat soup is superb medicine for her, meat treated with milk or mixed with sour articles or salt is also beneficial.

Hārta has advised use of *sārava* (an edible tuber) and consupinating articles along with their juice and all other congenial and beneficial diets and behaviour. In fifth and eighth months after performing auspicious rites, she should offer food to *brāhmaṇas* and family members.

Bhāvapraśāsa has followed Suśruta. Yogaratnākara has enlisted following articles beneficial for pregnant woman i. e. *śālā* and *śasika* rice, *mudga* (green gram), wheat, flour of parched rice, butter, *ghṛta*, milk, *rasāla* (curd mixed with sugar and condiments), honey, sugar, jack-fruit, banana, fruit of *amalaki*, *drākṣa*, sour and sweet substances; anointment with cooling agents, musk, sandal and camphor; wearing of garlands; moonlight bath, massage, soft bed, cool air, anabolic or gratifying edibles, embracing beloved and other pleasing mode of life along with desired food.

गर्भिणी के स्नानार्थ विशिष्ट जल (Specific water for pregnant woman's bath)

बिचकार्पासीफमृगणापाटलीपिचुम्बानिर्मम्यमांसीवर्धमानकपधङ्गकाथेन शीतेन सर्वान्धोदकेन वा गर्भिण्याः प्रत्यहं स्नानमुपदिशेत् ॥ (अ० सं० शा० ३/१४)

वाजपयशश्ङ्गाश्वः शीतं स्नानेऽन्वहं हितम् ॥ (अ० ह० शा० १/६८)

बिल्व (बेलगिरी), कार्पास, फमृगणा (सरवाल), पाटली (मुलाब के पुष्पदल या पटला) पिचुम्ब, अर्जुनमय, जटांमसी और वर्धमानक (एरंड) के पत्रों को कूटकर बनाए गए क्वाथ को शीतल करके या सर्वान्धोदक से गर्भिणी को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि कटे हुए वातज पत्रों के क्वाथ को शीतल करके प्रतिदिन स्नान करना हितकर है ।

The cold decoction of pulp of *bilva*, *kārpāsa*, *phamphana*, (petals of rose), *pīcūmānda*, *arjunamāsi*, *jaṭmānsī* and pounded leaves of *eranda* or the water prepared with *sarvagandha* (all fragrant) drugs should be used for bathing by the pregnant woman, is the opinion of Vāgbhata, Vāgbhata II has advised use of cold decoction of pounded leaves of drugs capable of suppressing *vāta*.

गर्भिणी द्वारा मणि-धारण (Amulet for pregnant woman)

वैवृतं तु मणिं कृत्वा तं श्रेण्यां गर्भिणी सदा ॥ १८९ ॥ (का० सं० खि० १०)

त्रिवृत् की मणि बनाकर गर्भिणी स्त्री को हर समय श्रेणि में धारण करना चाहिए ।

The pregnant woman should wear the amulet made of *trivṛt* in her waist.

गर्भिणी का मासानुमासिक पथ्य एवं पथ्य-प्रयोग से लाभ (Monthwise dietary regimen for pregnant woman and its effect)

(अ) मासानुमासिक पथ्य (Month-wise regimen)

(१) प्रथम मास का पथ्य (Regimen for the first month of pregnancy)

प्रथमे मासे शङ्कित चेद्वर्षमापन्ना क्षीरमनुपस्कृतं मात्रावच्छीतं काले काले पिबेत् ; सातम्यमेव च भोजनं सायं प्रातश्च भुञ्जीत । (च० सं० शा० ८/३२)

विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमद्वितीयतृतीयमासेषु मधुरशीतद्रवप्रायमाहारमुपसेवेत् । (सु० सं० शा० १०/४)

प्रथमे मासि गर्भिणी क्षीरमुपसंस्कृतं मात्रावच्छीतं काले पिबेत् । तस्मिन्नपि चाढां द्वादशरात्रं क्षीरोद्धवं सर्पिः शालिपर्णीपलशाण्यां शृतं कनकरजतक्राशितशीतोदकानुपानं पिबेत् । स्वादुशीतं द्रवप्रायं सातम्यं च सायं प्रातःप्रातश्चेत् । न चाप्यङ्गोद्वर्तमानि सेवेत् (अ० सं० शा० ३/३)

गर्भ-प्राप्ति की आशंका होते ही प्रथम मास में गर्भिणी अनुपसंस्कृत (विना किसी औषधि आदि से संस्कार किया हुआ) दुग्ध समय समय पर मात्रा के अनुसार (अपनी अग्नि एवं शरीर-बल के अनुसार) पीये । सायं एवं प्रातः सातम्य हो भोजन करे ।

महर्षि सुश्रुत ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मास में मधुर, शीतल एवं द्रवप्राय आहार के सेवन का विधान बताया है ।

महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि प्रथम मास में गर्भिणी उपसंस्कृत (औषधि आदि के साथ पकाया हुआ) दुग्ध समय मात्रा अनुसार (अजीर्ण आदि न हो यह ध्यान रखकर, समय से अर्थात् प्रातः सायं दोनों समय) पीये । उसमें भी पहिले बारह दिन दुग्ध से उत्पन्न घृत (दुग्ध से निकाले नवनीत से बनाए घृत) को शालिपर्णी एवं पलाश से शृत करके (स्नेहपाक विधि से संस्कृत करके) स्वर्ण या चाँदी के साथ क्वथित शीतल जल के अनुपान से (गर्भिणी स्त्री) पीये । मधुर, शीतल एवं द्रवप्राय तथा सात्व्य आहार प्रातः एवं सायं करे । अभ्यंग, उद्वर्तन आदि का सेवन न करे । पाठभेद में अनुपसंस्कृत क्षीरपान का विधान है^१ ।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि प्रथम मास में मधुरघृते, परूषक तथा मधुकणुष आदि में से उपलब्ध द्रव्यों को नवनीत एवं मधु तथा मधुर द्रव्य (शर्करा) मिले हुए दुग्ध के साथ पीने को दे^२ ।

Dietetics advised by various authors in this month are as follows:

Caraka S. : Having doubt of conception from the first month itself she should take non-medicated milk repeatedly in desired quantity (considering her digestive power and strength). Congenial diet should be taken in morning and evening.

Susruta S. : Sweet, cold and liquid diet should be taken from first to third month.

Vāgbhaṭa I. : During first month the pregnant woman should take medicated milk (non-medicated in different edition), timely in specific quantity (the quantity which does not produce indigestion and the time or twice i. e. morning and evening). Even in these days

१. मात्रावच्छेदविषयस्य काले कालेऽप्रस्य द्वयोरेषि कालयोः, अतएवजीर्णदिनविहाय मात्रावदिति ।

(अ० सं० शा० ३/३ की इट्ट टी०)

२. क्षीरमनुपसंस्कृतं । (अ० सं० शा० ३/३ पाठभेद इट्टुव्या० पु०)

३. प्रथमे मासि यद्येवमुपस्कृतं मधुशुष्पाणि यथात्तमं । नवनीतेन पयो मधुमधुरं पापयेच्च ॥ (हो० सं० तु० स्था० ४९/१)

गर्भिणी-चिह्न एवं गर्भिणी-परिचर्या

२१९

for first twelve days she should take *ghṛta* extracted from milk (clarified butter extracted from milk) and medicated with *śālīparṇi* and *pālāśa*. water already boiled with gold or silver and cooled be taken as a after drink. Sweet, cold, liquid and congenial diet should be taken twice i.e. morning and evening. Massage of oil and rubbing of unguent should be avoided.

Hārīta S. : During first month out of *madhuyasī*, *parīṣaka* and *madhūkapsuṣpa* available drugs should be taken with butter and honey followed by use of sweetened milk.

(२) द्वितीय मास में पथ्य (Regimen for second month)

द्वितीये मासे क्षीरमेव च मधुरौषधसिद्धम् । (च० सं० शा० ८/३२)

.....द्वितीयमधुरशीतद्रवप्रायमाहारमुपसेवेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/४)

विशेषण द्वितीये मधुरौषधसिद्धं पयः पिबेत् । (अ० सं० शा० ३/४)

द्वितीय मास में मधुरवर्ण की औषधियों से साधित दुग्ध का हो सेवन करना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत ने प्रथम मास की ही भाँति इस मास में भी मधुर तथा शीत एवं द्रवप्राय आहार-सेवन वर्णित किया है ।

महर्षि वाग्भट ने भी द्वितीय मास में विशेषकर मधुर औषधियों से साधित क्षीर-पान का विधान बताया है ।

महर्षि हारीत ने दूसरे-मास में काकोली से सिद्ध दुग्ध मधुर या मीठा करके पिलाने का निर्देश दिया है^१ ।

Caraka S. and Vāgbhaṭa I. : Milk medicated with *madhura* drugs.

Susruta S. : Sweet, cold and liquid diet.

Hārīta S. : Sweetened milk treated with *kākolī*.

(३) तृतीय मास में पथ्य (Regimen for third month)

तृतीये मासे क्षीरं मधुसर्पिर्भ्यामुपसंस्कृतम् । (च० सं० शा० ८/३२)

.....तृतीयमासेषु मधुरशीतद्रवप्रायमाहारमुपसेवेत्; विशेषतस्तु तृतीये षण्डिकौदनं पयसा भोजयेत् ॥

(सु० सं० शा० १०/४)

तृतीये तदेव सर्पिर्मधुष्याम् । (अ० सं० शा० ३/५)

तृतीय मास में मधु एवं घृत से संस्कृत किए हुए दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि तृतीय मास में प्रथम एवं द्वितीय सदृश ही मधुर, शीतल तथा द्रवप्राय आहार का सेवन करे, विशेषकर इस मास में पकाया हुआ षण्डि चावल दुग्ध के साथ भोजन करे ।

महर्षि वाग्भट ने भी इस मास में मधु एवं सर्पि के साथ दुग्ध प्रयोग वर्णित किया है ।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि तृतीय मास में कृशरा का प्रयोग श्रेष्ठ है^२ ।

Caraka S. and Vāgbhaṭa I. : Milk with honey and *ghṛta*.

Susruta S. : Sweet, cold and liquid diet, specially cooked *śaṣṭi* rice with milk,

१. द्वितीये मासि काकोली मधुरं पापयेत्तथा ॥ (हो० सं० तु० स्था० ४९/२)

२. तृतीये कृशरा श्रेष्ठा । (हो० सं० तु० स्था० ४९/२)

Hārīta S. : Kīrāṇā (olio prepared with rice and pulse).

(४) चतुर्थ मास में पथ्य (*Regimen for fourth month*)

चतुर्थ मासे क्षीरवनीतमक्षमात्रमश्रीयात् ॥ (च० सं० शा० ८/३२)

..... षष्टिकौदनं चतुर्थे दद्यात्१ चतुर्थे पयोवनीतससृष्टमाहारयेनाङ्गलमांससहितं हृद्यमनं

भोजयेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/४)

चतुर्थेऽक्षमात्रवनीतयुक्तम् ॥ (अ० सं० शा० ३/६)

चतुर्थ मास में दुग्ध तथा नवनीत या दुग्ध से निकाले नवनीत को अक्ष (२ तोले) की मात्रा में सेवन करे।

चतुर्थ मास में दुग्ध तथा नवनीत या दुग्ध से निकाले नवनीत को अक्ष (२ तोले) की मात्रा में सेवन करे। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि इस मास में षष्टि चावल के ओदन को दीर्घ के साथ देना चाहिए तथा दुग्ध एवं नवनीत से संस्कृत तथा जंगल प्राणियों के मांस के साथ हृद्य (रक्षिकर) अन्न भोजन के लिए देना चाहिए।

महर्षि वाग्भट ने भी चतुर्थ मास में अक्षमात्र (२ तोले) नवनीत से युक्त दुग्ध सेवन का विधान बताया है। महर्षि भेल ने चतुर्थ मास के प्रातः होने पर दुग्ध में नवनीत मिलाकर तथा महर्षि हारीत ने संस्कृत आंजन के प्रयोग का वर्णन किया है।

Caraka S. : Butter extracted from milk in the quantity of one akṣa or milk with butter.

Suśruta S. : Cooked saṣṭī rice with curd, dainty and pleasant food mixed with milk and butter and meat of wild animals.

Vāgbhaṭa I. : Milk with one akṣa of butter.

Bhela S. : Milk with butter.

Hārīta S. : Medicated cooked rice.

(५) पञ्चम मास में पथ्य (*Regimen for fifth month*)

पञ्चमे मासे क्षीरसर्पिः ॥ (च० सं० शा० ८/३२)

..... षष्टिकौदनं पञ्चमे पयसा; जाङ्गलमांससहितं हृद्यमन्नं पञ्चमे क्षीरसर्पिः

संसृष्टम् ॥ (सु० सं० शा० १०/४)

पञ्चमे क्षीरसर्पिः ॥ (अ० सं० शा० ३/७)

पंचम मास में क्षीर एवं घृत या क्षीरदधृत घृत का प्रयोग करे।

महर्षि सुश्रुत ने पंचम मास में षष्टिक ओदन का दुग्ध के साथ तथा जंगल मांस युक्त हृद्य अन्न का क्षीर एवं सर्पि के साथ भोजन करने का निर्देश किया है।

महर्षि वाग्भट ने दुग्ध से निकाले घृत (दुग्ध से निकाले मक्खन से बनाए घृत) के प्रयोग का वर्णन किया है।

महर्षि भेल ने पंचम मास में क्षीर और यवगू तथा हारीत ने पयस के प्रयोग का निर्देश किया है।

महर्षि चतुर्थ मासे प्रतिबिहिते क्षीर नवनीतं प्राश्रीयात् ॥ (पे० सं० शा० ८/६)

१. चतुर्थे खलु मासे प्रतिबिहिते क्षीर नवनीतं प्राश्रीयात् ॥ (पे० सं० शा० ८/६)

२. चतुर्थे च कौतदनं ॥ (हा० सं० तु० स्था० ४९/२)

३. पञ्चमे क्षीरदधृत सर्पिः १ (अ० सं० शा० ३/७ को इन्द्र टी०)

४. पञ्चमे क्षीरवगाः ॥ (पे० सं० शा० ८/६)

५. पञ्चमे पयसं दद्यात् ॥ (हा० सं० तु० स्था० ४९/३)

Caraka S. and Vāgbhaṭa I. : Ghṛta prepared with butter extracted from milk.

Suśruta S. : Cooked saṣṭī rice with milk, meat of wild animals along with dainty food mixed with milk and ghṛta.

Bhela S. : Yavagūṇā (rice gruel).

Hārīta S. : Pāyasa (rice cooked with milk and sweetened).

(६) षष्ठ मास में पथ्य (*Regimen for sixth month*)

षष्ठे मासे क्षीरसर्पिर्मधुरौषधसिद्धम् ॥ (च० सं० शा० ८/३२)

षष्ठे श्वदंष्ट्रसिद्धस्य सर्पिषो मात्रां पाययेद् यवगूं वा ॥ (सु० सं० शा० १०/४)

षष्ठे तदेव मधुरौषधसिद्धम् ॥ (अ० सं० शा० ३/८)

छठवें मास में मधुरावर्ग की औषधियों से सिद्ध क्षीरसर्पि का प्रयोग करना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत के मत से षष्ठ मास में गोक्षुर से सिद्ध घृत या (गोक्षुर से सिद्ध) यवगू का मात्रानुसार पान करना चाहिए।

महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि षष्ठ मास में उसे ही अर्थात् क्षीरसर्पि को मधुरौषध से सिद्ध करके देना चाहिए। महर्षि भेल ने क्षीरसर्पि तथा हारीत ने मोटे दही के प्रयोग का विधान बताया है।

Caraka S. and Vāgbhaṭa I. : Ghṛta (prepared from milk) medicated with the durgs of *madhura* group.

Suśruta S. : Ghṛta or rice gruel medicated with *gokṣura*.

Bhela S. : Ghṛta prepared with butter extracted from milk.

Hārīta S. : Sweetened curd.

(७) सप्तम मास में पथ्य (*Regimen for seventh month*)

तदेव सप्तमे मासे ॥ (च० सं० शा० ८/३२)

सप्तमे सर्पिः पृथक्पृथगदिस्मिद्धम् ॥ एवमाप्यायते गर्भः ॥ (सु० सं० शा० १०/४)

सप्तमे च १ (अ० सं० शा० ३/९)

सप्तम मास में भी उसी का अर्थात् मधुरौषध साधित क्षीरसर्पि का प्रयोग करना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत के मतानुसार सप्तम मास में पृथक्पृथग् आदि से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार गर्भ की वृद्धि होती है। टीकाकार इत्थण ने पृथक्पृथगदि से विद्वारिगन्धादि वर्ग की औषधियों को लेने का निर्देश दिया है।

महर्षि वाग्भट ने सप्तम मास में भी वही अर्थात् षष्ठ मास सदृश मधुरौषध साधित क्षीरसर्पि प्रयोग का निर्देश किया है।

हारीतसंहिताकार ने घृतखण्ड के प्रयोग का विधान बताया है।

१. षष्ठे क्षीरसर्पिः ॥ (पे० सं० शा० ८/६)

२. षष्ठे च मधुरं दीर्घम् ॥ (हा० सं० तु० स्था० ४९/३)

३. पृथक्पृथगदिः विद्वारिगन्धादिः १ (सु० सं० शा० १०/४ को इत्थण टी०)

४. सप्तमे घृतखण्डेन १ (हा० सं० तु० स्था० ४९/३)

and Vāṇabhūta 1: Same as in sixth month.

Suśruta S. : *Ghrita medicated with prithakpaniyūdi (vidūrigandhādī) group of drugs,*

Hārīa S. : Ghṛtaḥaṇḍa (a sweet dish).

(८) अष्टम मास में पथ्य (Regimen for eighth month)

अष्टमे तु मासे क्षीरयवान् सपिप्पत्तो काले काले पिबेत् ; तत्रोति भद्रकालः, पैङ्गल्याबाधो ह्यस्या गर्भमागच्छेदिति ; अस्त्वत्र पैङ्गल्याबाध इत्याह भगवान् पुनर्वसुग्राहयः, न त्वेवैतन्न कार्ष्ण्यम् ; एवं कुर्वतीनापि श्रेष्ठपपत्वं जनयति ॥ (च० सं० शां० ८/३२)

[illegible]

अष्टमे क्षीरयवाणं सर्षिभर्ता पिबेत् । नेति खण्डकाप्यो गर्भस्य पैङ्गल्याबाधप्रथात् । आस्त
पैङ्गल्याबाधस्तथाप्येवं कुर्यात् । नीरजं बलवर्णसत्संहननसम्पदुषेर्ज्ञातीनामग्राण्यमपत्यं जनयतीति भगवानाश्रयेः । आस्त
बदरोदकेन पलतपयोदधिभस्तुलैतलवफणपलतधृतमधुयुक्तोनासथापयेत् । पुराणविद्विशुद्धार्थं मधुकादिमधुरौषधसिद्धेन
च तैलेनानुवासयेन्नुलेमानाय वायोः । अनुलोमो हि मरुते सुखमनुपद्रवा प्रसूते । गर्भिणीं तु न्युब्जामा-
स्थापयेदनुवासयेद्वा । तथाऽस्या विवृतमार्गान्नाय सम्यगौषधमनुप्रविशति । अत ऊर्ध्वं त्रिधाधाभिर्दवाणुभिर्जालसै-
न्धेनान्येन्यपमवकलिति भगवान्यन्वन्त्तिः ॥ (अ० सं० शां० ३/११)

मधुरैः साधितं शब्दैः पुराणश्रुतस्तथा॥

क्षतापया च पयाऽन सद्वाताज्जना । दू० ६० ३
शुष्कपूलककोलाऽप्लकापायेण प्रशस्यते । शनाह्वकलिकनो वसिः
सर्तौलपृतसैश्वः॥
(३१० इ० शा० १/६४, ६५)

अठार्वें मास में दुग्ध से बर्ना हुई एवं घृत मिश्रित यवागु समय पर पीये। महर्षि भद्रकाय का कथन है कि यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके देने से गर्भ में पैलव्य (पिंगलता या पीलापन) आ जाता है। भगवान पुनर्दसु अत्रेय का कथन है कि ठीक है कि पैलव्य बाधा होती है, परन्तु (इस बाधा के कारण) यह (क्षीरयवागु प्रयोग) अकार्य नहीं है; ऐसा करने से अर्थात् क्षीरयवागु देने से गर्भिणी निराग रहकर आरोग्य, बल, वर्ण, स्वर तथा संहनन की उत्तमता से युक्त जाति-वन्धु-बायवों में उत्तम सन्तान उत्पन्न करती है। टीकाकार चक्रपाणि ने पैलव्य से पिंगल-नेत्रता मानकर क्षीरयवागु का प्रयोग का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि क्षीरयवागु का प्रयोग अल्पदोषकारक होता है, परन्तु बाद में बहुत ही गुणाप्रद एवं लाभ देने वाला होता है अतः इसका प्रयोग करना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत के मतानुसार अष्टम मास में पुराने मल के शोधन तथा वायु के अनुलोमान करने का लिए बला, आतपकृष्ण, शल्यगुप्ता, पलता (पीसा हुआ तिल), दूध, दही का पानी या दही तथा मस्तु, तैल, लवण, मदनफल, मधु एवं घृत से मिश्रित बेर के क्वाथ से आस्थापन वर्तित दे। इसके पश्चात् दुग्ध एवं मधुर वर्ग की औषधियों के क्वाथ से साधिष्ठ तैल की अनुवासन वर्तित दे। वायु का अनुलोमान हो जाने से (स्त्री बालक को) सुख पूर्वक प्रसवित करती है तथा उदरद्व रहित (प्रसवार्ति) वर्तित दे। इसके पश्चात् प्रसक्तकाल तक तिन्त्रिय यन्त्राओं तथा जांगल मंससर द्वारा उपक्रम या चिकित्सा एवं सूक्तिकावस्थामें रहती है। इसके पश्चात् प्रसक्तकाल तक तिन्त्रिय यन्त्राओं तथा जांगल मंससर द्वारा उपक्रम या चिकित्सा

१. पैङ्गलं पिङ्गलनेता। पैङ्गल्यस्यात्पेषन्वाटुताकालं मुकप्रतिश्रियान्म क्षीयवाक्ववाशो बहुगुणतामात्
कर्तव्यम्.....। (च० सं० शा० ८/३९ की चक्र० टी०)

गार्भिणी-चिह्न एवं गार्भिणी-परिचर्या

۲۲۳

कोरे। इस प्रकार चिकित्सित स्त्री स्निग्ध शरीर वाली एवं बलवान होकर सुख के साथ उपद्रव रहित होकर प्रसवित होती है।

अष्टांगसंहकार ने महर्षि चक्र एवं सुश्रुत दोनों के ही वपनों का सामंजस्य करते हुए लिखा है कि आठवें मास में दुग्ध से बनी एवं घृत मिश्रित यवागू पीने को देनी चाहिए। आचार्य छण्डकाय ने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके प्रयोग से गर्भ को पैंगल्य बाधा होती है, परन्तु भगवान् आश्रय का कथन है कि नहीं, पैंगल्य बाधा होने पर भी इसे (क्षीरयवागू) देना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से स्त्री निरोग, बल, वर्ण, सत्व एवं संहनन से युक्त, अपने बन्धु-बन्धवों में अग्रगण्य सन्तान को उत्पन्न करती है। बदरी के कथाय में पलत (तिलकल्क), दुग्ध, दही, मसु, तैल, लवण, मदनफल, घृत तथा मधु मिलकर आस्थापन बस्ति दे तथा पुराण मल-शोधन एवं वायु के अनुलामनाथं मधुश्री आदि मधुरोधधवर्ग से साधित तैल की अनुवासन बस्ति दे। वायु के अनुलाम हो जाने से स्त्री मुख से उपद्रव रहित होकर प्रसवित होती है। गर्भिणी को न्युब्ज स्थिति में ही आस्थापन या अनुवासन बस्ति देनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में माग के विवृत होने से (गर्भ एवं गर्भाशय के ऊपर छिंसक जाने के कारण) औषधि सम्पर्क प्रकार से प्रविष्ट हो जाती है। इसके पश्चात् प्रसवकाल तक न्निगध यवागूओं तथा जोगल मांसस द्वारा उपचार करे ऐसा भगवान् धन्वन्तरी का कथन है।

अष्टाङ्गहृदयकार का कथन है कि आठवें मास में घृत से युक्त क्षीरेया (दुग्ध) से बनी दक्का या खीर आदि) पीने को देनी चाहिए, तथा पुराण मल की शुद्धि के लिए मधुपर्वा की औषधियों से सिद्ध घृत से अनुवासन बरित देनी चाहिए; तथा शूष्क मूली, बेर एवं अमल पदार्थ में शतपुष्पा का कटक, घृत, तैल तथा सैन्धव लवण मिलाला बरित (निरुह) देनी चाहिए।

महर्षि हारीत ने इस मास में घृतपूरक या घेवर का प्रयोग बताया है^१।

Caraka says that in this month rice gruel prepared with milk and mixed with *ghṛta* should be given. Bhadrakāpya opines that it should not be given, because by use of this the child may become tawny in complexion. Punarvasu Ātreya agrees that it does produce tawny complexion, however, it is not useless, because by use of this the pregnant woman remains free from diseases, and delivers the child possessing best health, energy, complexion, voice, compactness of the body and much superior to other family members. Cakrapāṇi explains that since the side-effects are negligible and benefits much more hence it should be used.

Suśruta has indicated that in this month for clearing the retained feces and *anulomana* (regulation or putting in right direction) of *vāyu*, the *āsthāpana basti* (evacuative enema) should be given with decoction of *badarī* mixed with *balā*, *atibalā*, *śatapuspā*, *palala* (pested sesamum seeds), milk, curd, *mastu* (sour butter), oil, salt, *madanaphala*, honey and *ghṛta*. This should be followed by use of *anuvasāna basti* (uncting enema) of oil medicated with milk and decoction of drugs of *madhura* group. Due to movement of *vāyu* in its right direction the lady delivers without difficulty and remains free from complications. After this she should be given unctuous gruels and meat-soup of wild animals. The body of woman thus treated becomes unctuous, she gains strength and delivers normally without complications.

Vāgbhaṭa I has incorporated the description of both Caraka and Suśruta with only replacement of name of Bhadrakāpya to Khaṇḍakāpya and achievement of *satwa* (vitality)

१. चाष्टमे घृतापूरकम्। (हा० सं० तु० स्था० ४९/३)

also in the description of Caraka and deletion of three drugs i. e. *śatāpuspā*, *balā* and *aribālā* from the list of drugs for *asthāpana basti* advised by Sūśruta. He has advised that the enema should be given to the woman in bent or humpbacked position because in this position the passage becomes dilated and the medicine enters properly.

Vāgbhata II has advised use of liquid diet prepared with *ghṛta* and milk and *anuvasāna* enema prepared with *ghṛta* and drugs of *madhura* group for cleaning the collected feces. After this, the *nirūḥa basti* (enema) should be given with the decoction of *śūśkamūlī*, *badarī* and sour substances mixed with pestled *śatāpuspā*, *ghṛta*, oil and rock salt.

Hārīta has advised use of *ghṛtapūṛaka* (a kind of sweet preparation).

(१) नवम मास में पथ्य (Regimen for ninth month)

नवमे तु खल्वेतां मासे मधुरौषधिसंयुक्तं तैलेनानुवासयेत् । अतश्चैवास्यान्तत् पितुं योनौ प्रणयेद्गर्भस्थानमार्गस्नेहनाथम् (च० सं० शा० ८/३२)

नवमे तु तत् एवानुवासनतैलापितुं योनौ प्रणयेत् गर्भमार्गशययोः स्नेहनाथमिति ॥ (अ० सं० शा० ३/१२)

शस्तश्च नवमे मासि स्त्रियो मांससौदनः । बहुस्नेहा यवागूर्वा पूर्वोक्तं चानुवासनम् ॥ ६७॥

तत् एव पितुं चास्या योनौ नित्यं निधापयेत् । वातजपत्रभङ्गाग्नयः शीतं स्नानेनैवर्हं हितम् ॥ ६८॥

निःस्नेहाङ्गी न नवमासासाधयति वासयेत् ॥ ६९॥ (अ० ह० शा० १)

नवम मास में इस (गर्भिणी) स्त्री को मधुरवर्ग की औषधियों से समर्थित तैल को अनुवासन बरसि देनी चाहिए तथा गर्भस्थान एवं गर्भमार्ग के स्नेहनाथ इसी तैल की पितु योनि में धारण करनी चाहिए ।

अप्यङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि उसी तैल से (अष्टम मास में वर्णित मधुरौषध समर्थित तैल से) गर्भमार्ग एवं गर्भाशय के स्नेहनाथ योनि में पितु धारण करनी चाहिए ।

अप्यङ्गहृदयकार का निर्देश है कि नवें मास में स्नेह से युक्त मांसस तथा ओदन अथवा स्नेह-युक्त यवागूर का प्रयोग तथा पूर्ववर्णित (अष्टम मास में) अनुवासन का प्रयोग श्रेष्ठ है । उसी तैल की पितु योनि में नित्य धारण करनी चाहिए । कटे हुए वातज पत्रों के शीतल क्वाथ से नित्य स्नान हितकर है । सम्पूर्ण नवें मास में स्नेह-विरहित अंगों वाली स्त्री को अनुवासन नहीं देना चाहिए अर्थात् स्नेह-प्रयोग के बाद ही स्निग्ध अनुवासन बरसि देनी चाहिए ।

महर्षि हारीत ने नवें तथा दशम मास में विविध प्रकार के अन्न का प्रयोग बताया है^१ ।

महर्षि भेल ने इस नवें मास में कटुव्यामणतैल की अनुवासन बरसि का विधान बताया है इससे जीर्णपूरीष अधोमार्ग में चला जाता है एवं सामान्य प्रसव होता है । बाद में यवागूर-पान कराना चाहिए^२ ।

Caraka and Vāgbhata I have advised use of *anuvasāna basti* with oil prepared with the drugs of *madhura* group or the same as used in eighth month (A.S.). Vaginal tampon of this very oil should be given for lubrication of *garbhashāna* (uterus but here cervix) and *garbhamārga* (vaginal canal and perineum).

Vāgbhata II has prescribed meat-soup with cooked rice and fat (preferably *ghṛta*) or

१. नवमे विविधाणि दशमे। (ह० सं० पू० स्था० ४९/३)

२. नवमे तु खलु मासे प्रतिविहिते कटुव्यामणतैलेन (वासयेत्) । एवं ह्यस्याः प्रतिसर्तकमासा (ग) याच्य (क्ष) त (स) मन्तं भवति, जीर्णपूरीषं चाधः स्ववसुधं च जायते अथैनं प्रजनिष्यतीति यवागूरं पापयेत् ॥ (भे० सं० शा० ८/७)

rice gruel mixed with good quantity of fat. *Anuvasāna basti* as advised in eighth month and vaginal tampon of the same oil should be given. Daily bath with cold decoction of pounded leaves of drugs capable of suppressing *vāta* should be given. To the woman having absence of unctuousness in the body *anuvasāna basti* should not be given for whole ninth month or in other words unctuous *anuvasāna basti* should be given only after use of fat.

Hārīta opines that in ninth and tenth month different varieties of cereals should be used.

Bhela says that *anuvasāna basti* with *kadamānasa* oil should be given, by use of this the accumulated feces goes in the lower passage, thus delivery of child becomes normal. After this (use of *basti*) rice gruel should be given.

विमर्श (Comments)

महर्षि सुश्रुत ने नवम मास के पथ्य का वर्णन नहीं दिया । अष्टम मास में बरसि-विधान-वर्णन के बाद प्रसवकाल तक स्निग्ध यवागूर एवं जाङ्गल-मांसस के द्वारा उपचार करने का निर्देश दिया है जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि नवम मास में स्निग्ध यवागूर एवं जाङ्गल-मांसस का प्रयोग निर्दिष्ट है ।

Though Sūśruta has not prescribed any specific dietetic regimen specifically for ninth month, however, in the regimen of eighth month after use of enema continuous use of unctuous gruels and meat-soup of wild animals upto the period of delivery is advised. This indicates that Sūśruta has advised use of unctuous gruel and meat-soup of wild animals in ninth month also.

(आ) मासानुमासिक पथ्य से लाभ (Benefits of monthly regimen)

परमतो निर्विकारमायाध्यायनस्य गर्भस्य मासे मासे कर्मोपदेश्यामः । । एवं कुर्वती ह्येतोऽस्योपबलवर्णस्तरसंहनसंपदुपेतं ज्ञातीनामपि श्रेष्ठमपत्यं जनयति । । यदिदं कर्म प्रथमं मासं समुपादयोपदिष्टान-नवमासासात्तेन गर्भिण्या गर्भसमये गर्भधारिणीकुक्षिकटीपार्श्वपूर्वपृष्ठं मूढभवति, वातश्चातुल्यमः संपद्यते, मूत्रपूरीषे च प्रकृतिभूते सुखेन मार्गानुपद्यते, चर्मनखाणि च मार्दवमुपयान्ति, बलवर्णौ चोपवीयते, पुत्रं चेष्टं संपदुपेतं सुखिनं सुखैषा काले प्रजायत इति । (च० सं० शा० ८/३२)

..... एवमायाध्याये गर्भः । अतुल्यो हि वायौ सुखं प्रसूयते निकपद्रवा च भवति । एवमुपक्रान्ता स्निग्धा बलवती सुखमनुपद्रवा प्रसूयते । (सु० सं० शा० १०/४)

अनेन प्रथममासादारभ्य क्रमेण गर्भिण्याः प्रसवकाले गर्भधारिणीकुक्षिकटीपार्श्वपूर्वपृष्ठं मूढ भवति । वायुश्चातुल्यमः संपद्यते । मूत्रपूरीषं च प्रकृतिभूतं जरायुश्च मार्गं प्रतिपद्यते । पुत्रं चेष्टं कल्याणमुप्यन्तं सुखिनं सुखेन काले बलवती प्रसूते ॥ (अ० सं० शा० ३/९३)

महर्षि चक्र ने कहा है कि विकार रहित बढ़ते हुए गर्भ के लिए प्रत्येक मास में किए जाने वाले कर्म का निर्देश करकेगा अर्थात् मासानुमासिक पथ्य गर्भ के विकार रहित हो सामान्य वृद्धि के लिए हितकर है । इसके करने से स्त्री स्वस्थ रहकर आरोप्य, बल, वर्ण, स्वर तथा संहनन से युक्त सम्पूर्ण जाति में श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करती है । प्रथम से नवम मास तक के लिए वर्णित उपक्रम से गर्भिणी के गर्भ समय में (गर्भाधान से प्रसवोपरान्त) गर्भधारिणी, कुक्षि, कटि, पार्श्व एवं

१. गर्भधारिणी को टीकाकार चक्रपाणि ने अपरा माना है (गर्भधारणी अपरा च० सं० शा० ८/३२ की चक्र० टीका) । इदुत् ने गर्भधारणी को कोई व्याख्या नहीं की । चक्र के पाठभेद में 'गर्भधारिणी' लिखा है, जिसका अर्थ 'गर्भ के धारण में'

पृष्ठ मृदु होते हैं, बाल का अनुलोमन होता है, मूत्र एवं पुरीष मर्यादाविक रूप में सुखपूर्वक अपने मार्ग में निकलते हैं। चर्म एवं नाख आदि में मृदुता आ जाती है। (गर्भिणी में) बल-वर्ण का उपचय होता है, वह अर्काश्रित, सर्वगुण-सम्पन्न, सुखी एवं स्वस्थ पुत्र को सुखपूर्वक उत्पन्न काल में जन्म देती है।

यद्यपि महर्षि सुश्रुत ने मासानुमासिक पञ्च के नामों का पृथक् उल्लेख नहीं किया, परन्तु सामान्य पञ्च के वर्णन में ही यत्र-तत्र नामों का भी उल्लेख है जैसे इस प्रकार से गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है। वायु के अनुलोम होने से मूत्रपूर्वक प्रसव करती है तथा उपद्रव रहित रहती है। इस प्रकार का उपक्रम करने से (गर्भिणी) स्त्री म्निष्य एवं बलवान् होती है तथा सुखपूर्वक उपद्रव-रहित हो प्रसव करती है।

महर्षि वाग्भट ने चरक सद्गुण ही लिखा है कि इस प्रकार प्रथम मास से प्रारम्भ कर क्रमशः यह क्रम करने से गर्भिणी के गर्भधारिणी, कुक्षि, कटि, पाश एवं पृष्ठ मृदु होते हैं। वायु का अनुलोम होता है, मूत्र, मल एवं प्रसवकाल में गर्भिणी के गर्भधारिणी, कुक्षि, कटि, पाश एवं पृष्ठ मृदु होते हैं। वायु का अनुलोम होता है, मूत्र, मल एवं जरायु स्वाभाविक होकर अपने मार्ग में आ जाते हैं। स्त्री बलवान् होकर इच्छित, श्रेष्ठ, दीर्घायु एवं सुखी पुत्र को सुखपूर्वक प्रसवित करती है।

गर्भिणी के आहार-विहार की उपदेयता का वर्णन करते हुए महर्षि चरक, काश्यप, भेल एवं टीकाकार इत्यादि ने स्पष्ट किया है कि गर्भिणी स्त्री द्वारा लिए हुए आहार-विहार से ही गर्भिणी स्त्री के शरीर के साथ गर्भधारिणीस्थित गर्भ का पोषण होता है, साथ ही स्तन या स्तन्य (चरक, काश्यप भेल एवं इत्यादि मलानुसार) का भी गर्भिणी स्त्री के आहार से उत्पन्न रस से ही पोषण होता है।

Describing the benefits of this dietetic regimen prescribed for the woman having normal development of fetus, Caraka says that by this the woman remains healthy and delivers the child possessing good health, energy or strength, voice, compactness and much superior to other family members. Further he and Vagbhata I say that by the use of this regimen from first to ninth month her *garbhadhārīnī* (fetal membranes or vaginal canal), *kukṣi* (abdomen), sacral region, flanks and back become soft, *vāyu* moves into its right path or direction: feces, urine and nail become soft (C.), woman gains strength and complexion and she delivers easily at proper time a desired, excellent, healthy child possessing all the qualities and long life.

Sūśruta has not described benefits separately, however, some of them mentioned here and there inbetween the monthwise regimen are—that by this the fetus attains good growth, *vāyu* moves in its right direction, woman becomes unctuous, strong and delivers the child easily without complications.

पृष्ठ २२५ से क्रमशः

होता है अर्थात् गर्भ-गर्भिक के समय एवं गर्भधारण-काल में उपर्युक्त अङ्ग मृदु होते हैं, परन्तु इससे भी कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि मासानुमासिक पञ्च गर्भधारण के बाद की प्रक्रिया है। यदि चरकालिखित गर्भ-समय से गर्भ का प्रसवकाल अर्थ करें जो अष्टाङ्गसंग्रह में स्पष्टर शब्दों में लिखा है एवं गर्भधारणी से अपरा के स्थान में गर्भधारिणी कला (गर्भ की धारण करने वाली कला या एम्ब्रिऑनिक तथा कोरिऑनिक कला) अर्थ करें तो विषय कुछ स्पष्ट हो जाता है। गर्भधारिणी शब्द खीलितङ्ग होने से गर्भधारण का द्योतक नहीं हो सकता, परन्तु योनि के लिए ले सकते हैं, अर्थात् गर्भधारिणी योनि जिसकी मृदुता प्रसव के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इस वाक्य का स्यादिकरण इस प्रकार कर सकते हैं कि मासानुमासिक पञ्च से प्रसवकाल में गर्भधारिणीकला (एम्ब्रिऑनिक एवं कोरिऑनिक कला) या योनि एवं कुक्षि आदि मृदु हो जाते हैं।

१. च० सं० शा० ६/२३, का० सं० सू० १८/६, ७, १० सं० शा० ५/७ (गर्भपोषण पृष्ठ १४३ से १४६)

Emphasizing the importance of woman's diet authors have mentioned that the *rasa* derived from the diet taken by the pregnant woman serves three purposes (1) nourishment of her own body, (2) nourishment of the fetus and (3) nourishment of breast or formation of milk which has already been discussed under fetal nourishment.

विमर्श (Comments)

गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में अधिकांशतः स्त्रियों को छर्दि एवं हृल्लस की अनुभूति होती है, अतः वे सामान्य आहार ले सकने में असमर्थ होती हैं। मधुर, शीतल, द्रव-प्राय आहार का सेवन वमन-जन्य शारीरिक जलीयता की क्षति को पूर्ति एवं सामान्य पोषण करेगा तथा मधुरवर्ण को औषधियाँ वृंहण होने के कारण गर्भ एवं गर्भिणी के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगी। चतुर्थ मास से गर्भ की मांस धातु का विशेष रूप से निर्माण होने के कारण गर्भिणी को प्रोथेजिन की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जङ्गल-मांसरस सेवन-द्वारा समुचित रूप से हो सकती है। द्वितीय त्रैमासोपरान्त अधिकांश स्त्रियाँ अत्यधिक पादशोष या अन्य जल-सञ्चय-जन्य उपद्रवों का अनुभव करती हैं; षष्ठ मास में प्रयुक्त गोधूर मूत्रल होने के कारण शरीर में जल का सञ्चय न होने देकर इन उपद्रवों का प्रतिषेध करेंगी। पृथक्पृथग्निदि या विदारिण्य-आदि वर्ण की औषधियाँ मूत्रल, वृंहण, शोष-नाशक तथा पित्त एवं कफ-नाशक हैं, अतः इनका सतत मास में नियमित प्रयोग गर्भ एवं गर्भिणी के स्वास्थ्य का संरक्षण करेगा। उदरगुहान्तर भात-वृद्धि, आन्त्र-पीडन तथा प्रोबेस्टॉन के प्रभाव के कारण अधिकांश स्त्रियों को विबन्ध हो जाता है, जो गर्भावस्था के अन्तिम मासों में अधिक कष्टदायक होता है, अतः अष्टम मास में बलित के प्रयोग से इस विबन्ध का निवारण होगा। यह भी संभव है कि अष्टम या नवम मास में प्रयुक्त बलित गर्भधारण-मांसपेशी के कार्य का नियामन करने वाले नाडीतन्तुओं को भी प्रभावित करती हो तथा उनके कार्य का नियामन कर प्रसवकाल में उपस्थित होने वाले गर्भशय मांसपेशी-कार्बन-उपद्रवों का प्रतिषेध करे। सम्भवतः तैल के पिचुधारण से योनिनलिका-स्थित औषधीय कटिण्डुओं का नाश होता हो जिससे सूतिकाकाल में उत्सर्ग होने की सम्भावना कम हो जाती हो, योनिपथ की मृदुता हो वह प्रसव में सहायक होती हो तथा किसी प्रकार गर्भशय-पेशी-नियामक नाडीतन्तुओं पर प्रभाव डालकर प्रसव के समय गर्भशय-पेशी के कार्य में सहायक होती हो। यह मूलाधार को मृदु कर प्रसव के समय उसके शिथिलीकरण में भी सहायक हो सकती है।

मधुरवर्ण की औषधियाँ तथा दुग्ध का प्रयोग सम्पूर्ण गर्भावस्था में निर्दिष्ट है। दुग्ध स्वयं में एक पूर्ण भोजन है। मधुरवर्ण की औषधियाँ वृंहण हैं, अतः इन दोनों के प्रयोग से गर्भ एवं गर्भिणी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

During first trimester of pregnancy most women experience nausea and vomiting, thus can not take proper diet. Use of cold and sweet liquid diet and milk will prevent dehydration and supply required nourishment, besides the drugs of *madhura* group being anabolic will help in maintenance of proper health of mother and fetus. Fourth month onwards muscular tissue of fetus grows sufficiently requiring more protein which is supplied by use of meat-soup. By the end of second trimester most women suffer from edema of feet and other complications of water accumulation. Use of *gokṣura* a good diuretic in sixth month will prevent retention of water as well as its complications. The drugs of *vidāriṅgadhadi* group are diuretic, anabolic, relieve emaciation and suppress *pitṭa* and *kapha*, their regular use in seventh month might help in maintaining health of mother and fetus. Most women experience constipation in late pregnancy due to pressure of gravid uterus over the bowels and effect of progesterone. Use of enema in eighth month will relieve this constipation, besides this may also affect the autonomous nervous system governing myometrium and help in regulating their function during labour. Tampon of oil may destroy pathogenic bacteria of

vaginal canal and prevent puerperal sepsis, besides this tampon may also soften vaginal passage thus help in normal labour. It is just possible that the regular use of tampon might influence autonomic fibres governing myometrium and help in regulating their functions. Besides, this might soften the perineum and help in its relaxation during labour.

Milk and drugs of *madhura* group have been advised for entire pregnancy period. Milk is a whole diet. The drugs of *madhura* group are anabolic, thus use of these will help in maintenance of proper health of mother and growth and development of fetus.

गर्भिणी के लिए सामान्य वर्ज्य अहार-विहार या गर्भोपधातकर भाव (Dietetics and mode of life contraindicated for pregnant woman or garbhopadhakara bhavas i. e. factors likely to harm the fetus)

गर्भिणी तीक्ष्णौषधव्यायव्यायामवर्जनीयानां । (च० सं० सू० २५/४०)

गर्भोपधातकारस्त्रियमे भावा भवन्ति, तद्यथा-सर्वमतिगुरुष्णतीक्ष्णं दारुणाश्च चेट्याः, इमांश्चान्यनुपदिशन्ति वृद्धाः-देवतारक्षोऽनुचरपरिरक्षणार्थं न रक्तानि वासांसि बिभृयात्र मदकाराणि मद्यान्यभ्यवहरेन्न यानमधिरोहेन्न मांसमश्रीयात् सर्वेन्द्रियप्रतिकूलंश्च भावान् दूरतः परितर्जयेत्, यच्चान्यपि किञ्चित् स्त्रियो विदुः ॥

(च० सं० शा० ४/१८)

तदा प्रभृति व्यायाममतिगुरुमतिकर्शनं दिवास्वप्नं रात्रिजागरणं शोकं यानावरोहणं भयमुत्कुटुकानसं चैकान्ततः स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं च काले वेगविधारणं च न सेवेत ॥ (सु० सं० शा० ३/१६)

गर्भिणी प्रथमदिवसात् प्रभृति मतिनविकृतहीनात्राणि न स्पृशेत्, दुर्गन्धदुर्दानि परिहेत्, उद्वेजनीयाश्च कथाः शुष्कं पयुषितं कुशितं क्लिप्तं चात्रं तोपभुञ्जीत, वह्निर्निष्क्रमणं शून्त्यागारचैत्यश्रमशान्तक्षेत्रान् क्रोधमयशक्तंश्च भावान् चैर्भाष्यादिकं च परिहेत् यानि च गर्भं व्यापादयन्ति, न चाग्निं तैलाभ्यङ्गोत्सादनदीनि निषेवेत, न चायासयेच्छरीरं, पूर्वोक्तानि च परिहेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/३)

गर्भिणी तीक्ष्णौषधव्यायव्यायामवर्जनीयानाम् । (अ० सं० सू० १३/३)

तत्रमे गर्भोपधातकराः । तद्यथा-व्यायव्यायाममकर्शनीभिधाततिमात्रमदृष्टोभिधानयानरात्रिजागरणदिवस्वप्न-वेगविधारणाजीर्णार्तपात्रिकोषशोकभयोत्तासोपवासोत्कटकविषमकठिनसनश्चक्रूपप्रपाताप्रियावलोकनश्चवृणादयः । समसतः सर्वमतिगुरुष्णतीक्ष्णरुक्षमन्नपानं दारुणाश्च चेट्याः ॥

तथा-देवतारक्षोऽनुचरपरिरक्षणार्थं न रक्तानि वासांसि धारयेन्न यानमधिरोहेन्न मद्यमांसमश्रीयात् । यच्चान्य-दपि वृद्धस्त्रियो बूधुः ।

तस्मात्तज्जासंदापिच्छन्ती साध्यात्सानमुपाचरेत् । विशेषेण नारी ॥ (अ० सं० शा० २/६० से ६२)
.....न चाभ्यङ्गोद्वर्तनानि सेवेत । यथोक्तानि च दोषकराणि परिहेत्तापञ्चाम्नासात् ॥

(अ० सं० शा० ३/३)

अतिव्यायामपासं भारं प्रावरणं गुरु । अकालजागरस्वप्न कठिनोत्कटकानाम् ॥ ४४ ॥
शोकक्रोधभयगद्गेगवेगशब्दव्याधिराणम् । उपवासोव्यातीक्ष्णोष्णगुरुविधिभ्रमोजनम् ॥ ४५ ॥

रक्तं निवसनं श्वभक्षूपेक्षां मद्यमभिषम् । उत्तानशयनं यच्च स्त्रियो नेच्छन्ति तत्त्वजेयम् ॥ ४६ ॥
तथा रक्तवृत्तिं शुद्धं बस्तिमासासतोऽष्टमात् । (अ० ह० शा० १/४४ से ४७)

क्षीयमाणं च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करं । न पश्येद्गर्भिणीनित्यं नाप्युभौ राहुदरुणे ॥

सोमाकौ संग्रहौ शुक्ल गर्भिणी गर्भवेश्मनि । शान्तिहेमपाऽऽसीत मुक्तयेगं तु याचयेत् ॥
न द्विधादतिथिं भिक्षां दद्यान्न प्रतिवारयेत् । स्वयं प्रज्वलिते चानौ शान्त्यर्थं जुहुयादधृतम् ॥
पूर्णाकुम्भं घृतं माल्यं पूर्णपात्रं घृतं दधि । न किञ्चित् प्रतिशयीयात्र च बन्धीत गर्भिणी ॥
सूत्रेण तनुना रज्ज्वा स्तम्भनं बन्धनानि च । वर्जयेद्गर्भिणी नित्यं कामं बन्ध्यानि मोक्षयेत् ॥

नैवोक्ता न प्रज्ञाता न गुह्यं धारयेच्चिरम् । उद्वेजनं तथा हारस्यं सङ्घातं चापि वर्जयेत् ॥
(का० सं० शा० ५/१६-२०)

(का० सं० चि० २/१५)

गर्भिणी के लिए तीक्ष्णौषध प्रयोग, व्यायाम तथा व्यायाम वर्ज्य है । आगे वर्णित भाव या कार्य गर्भ को उपधात या नष्ट करने वाले होते हैं जैसे सभी अत्यधिक गुरु, उष्ण एवं तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन, दारुण चेट्या (स्वर्णादि से अधिक की चेट्या) । ये सभी तथा अन्य जो वृद्ध लोग उपदेश करते हैं यथा-(गर्भिणी स्त्री) देवता, राक्षस एवं उनके अनुचरों से रक्षा के हेतु रक्त वस्त्र धारण, मदकारक द्रव्यों एवं मद्य का सेवन न करे, सवारी (ऊँची नीची या असमान रास्ते पर जाने वाली) पर न चढ़े, मांस न खाए तथा अन्य सभी इन्द्रियों के प्रतिकूल या हानिकारक भावों (कार्यों या पदार्थों) का दूर से ही परित्याग करे तथा और भी जो स्त्रियाँ बताए वह न करे ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि उसके बाद से (गर्भाधान के बाद से गर्भिणी स्त्री) भैशुन, व्यायाम, अतिवर्णन, अतिकर्शन, दिन में सोना, रात्रि-जागरण, शोक, यान-रोहण, भय, उकड़ बैटना आदि को बिल्कुल ही तथा स्नेहादि क्रिया एवं रक्तमोक्षण का अकाल में सेवन तथा वेग-विधारण न करे । अन्यत्र स्पष्टीकरण दिया है कि भैशुन करने से गर्भ को पीड़ा होती है ।
गर्भिणी-स्त्री प्रथम दिवस से ही मलिन, विकृत या हीन अङ्गों वाले (व्यक्ति) को स्पर्श न करे, दुर्गन्धित एवं दुर्दर्शन (देखने में बुरे लगने वाले) पदार्थों का तथा उद्वेग उत्पन्न करने वाली कथाओं का परित्याग करे । शुष्क, बासी, सड़ा हुआ तथा क्लिप्त अन्न न खाए । बाहर निकलने, शून्य-गृह, चैत्य (देवालय का वृक्ष), श्मशान एवं वृक्षाश्रय में जाने, क्रोध तथा अयशकारी भाव, ऊँची आवाज में बोलने आदि का तथा अन्य गर्भ को बाधा पहुँचाने वाले भावों का परित्याग करे । अत्यधिक तैलाभ्यङ्ग एवं उत्सादन (उबटन) आदि का सेवन न करे । शरीर को (बहुत) न धकावे एवं पहिले बताई हुई (ऊपर लिखा हुई बातों) का परित्याग करे ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने वर्णन किया है कि गर्भिणी को तीक्ष्णौषध-प्रयोग, व्यायाम एवं व्यायाम वर्ज्य है । गर्भोपधातक ये भाव हैं-जैसे (अत्याधिक) भैशुन, व्यायाम, कर्शन, अभिघात, अत्याधिक संक्षेप उत्पन्न करने वाले यान एवं वाहन^१, रात्रि-जागरण, दिन में सोना, वेगधारण, अजीर्ण होना, आतप एवं अग्नि (का सेवन), क्रोध, शोक, भय, उत्रास (विकृत होना), उपवास, उत्कट, विषम एवं कठिन आसन; गढ़े या कुयें में गिरना, अप्रिय को देखना या अप्रिय शब्द सुनना आदि, संक्षेप में सभी प्रकार के अतिगुरु, उष्ण, तीक्ष्ण एवं रक्ष अन्नपान का सेवन एवं दारुण चेट्यायें । देवता एवं राक्षसों के अनुपचय या अनुपघात^२ के लिए (अनुचरों से राक्षस) रक्त वर्ण वस्त्र न पहने, सवारी में न चढ़े, मद्य एवं मांस आदि का सेवन न करे तथा अन्य जो भी वृद्ध स्त्रियाँ कहें वह न करे ।

इसलिए श्रेष्ठ संतान की कामना करने वाले माता-पिता विशेषकर स्त्री अपने को भी श्रेष्ठ बनावे । (प्रथम मास में)

१. सु० सं० चि० २४/१२३ (पृष्ठ ८३)

२. यान शब्देन वाहनानिषेधेन..... । (अ० सं० शा० २/६० की इन्दुटीका)

३. 'अनुपचय या एकत्रीकरण न होना' शब्द का प्रयोग यद्यपि पूर्णरूपेण अनुचित तो नहीं कहा जा सकता परन्तु उक्त युक्तिसंगत भी नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार के विकार को उत्पन्न करने के लिए देवता या राक्षसों का कहना भी उपचय नहीं होता । टीकाकार इन्दु ने 'अनुपघात' शब्द का प्रयोग किया है । स्त्री के रक्त वस्त्र आदि के धारण से देवता या राक्षस के अनुपघात का भी प्रश्न नहीं उठता । उपर्युक्त सन्दर्भ में महर्षि चरक ने 'अनुपचय' के स्थान में 'अनुचर' शब्द का प्रयोग किया है जो अधिक युक्तिसङ्गत है अतः कोष्ठक के अन्दर 'अनुचर' शब्द लिखा गया है ।

अथङ्ग एवं उदरदन्त का सेवन न करे तथा पाचवां माह प्राप्त होने तक (या चार माह पूरे होने तक) दोषकर पदार्थों का परित्याग करे।

अथङ्गहृदयका ने भी लिखा है कि गर्भिणी स्त्री को अति मैथुन, अत्यधिक पर्वाश्रम, भागवहन, भारी कपड़ा ओढ़ना, अकाल या अनुचित समय में सोना या जाना, कठिन एवं उत्कट आसन, शोक, क्रोध, भय, उद्वेग, केप एवं इच्छा का धारण, उपवास, अत्यधिक चलना, तीक्ष्ण, उष्ण, गुरु एवं विष्टिभूमी भोजन, रक्त वस्त्र का धारण, गर्ह या कुंघे में झँकना, मद्य, मांस, उन्नत-जनन एवं अन्य जो भी निर्व्यां निषिद्ध करें उन सभी का तथा रक्तमोक्षण, शोथन एवं आठवें मास तक वस्ति आदि का परित्याग करना चाहिए।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि गर्भिणी स्त्री क्षीण होते हुए चन्द्रमा (कृष्णपक्ष के चन्द्रमा), अस्त होते हुए सूर्य तथा दोनों गृहों (गृह एवं केतु) को न देखे। सूर्य या चन्द्र का ग्रहण सुनकर गर्भगृह पर के भीतर) में जाकर शान्ति एवं होम तथा ग्रह में निमोचन की प्रार्थना करे। वह अतिथि से द्वेष न करे, उसे पिशाच दं उसे जापस न भजे (विना पिशाच दिए या अतिथि किए)। स्वयं शान्ति के लिए प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति दे। वह भ्रू एवं घड़े, घृत, माला तथा दही या घृत से भरे पात्र आदि का प्रतिरोध न करे। सूत्र से या पतनी रस्सी आदि से स्तम्भन तथा बन्धन न करे तथा अपने सभी वस्त्रन खोल दे या ढीले कर दे अर्थात् कोई भी वस्त्र आदि बहुत कस कर अपने शरीर में न बाँधे।

गर्भिणी स्त्री को ऊँचे उठना, बहुत झुकना, देर तक भारी चीज को उठाए रखना, कैंपना, अधिक हँसना तथा सङ्घात या चोट आदि का परित्याग करना चाहिए। इसको शीतल जल एवं तलुन का प्रयोग निषिद्ध है।

महर्षि हरिती ने गर्भिणी के द्वारा परित्याज्य पदार्थों का परिणाम करते हुए लिखा है कि गर्भिणी को द्विदन्त अन्न (दालें आदि), विटही, गुरु एवं अन्न पदार्थ तथा उष्ण द्रव्य का परित्याग कर देना चाहिए। उसे मृत्तिका, सूर्यकन्द, रसेन तथा पातलाडु नहीं खाना चाहिए या सूरण एवं गौल्य (अति विषधकारक) पदार्थ रस सहित ही देने चाहिए एवं व्यायाम, मैथुन, क्रोध, शोक, भ्रूषण या दहलना आदि त्याग देना चाहिए इससे सुख की उत्पत्ति होती है।

आचार्य मान्वाभिन ने महर्षि सुश्रुत के वर्णन का शब्दभेद से पूर्णरूपेण पारुस्पर्य रूप में अनुगमन किया है केवल अन्त में अतिमृदु एवं अतिउच्च स्थान में शयन या बैठने का भी निषेध किया है। मैथुन के निषेध का कारण गर्भ को पीड़ा

१. गुर्वेणोषु च वर्जयेत् । (का० सं० खि० २३/१८)

२. मृत्तिका गर्भिणी शिथुः ॥ ३१॥

..... तलुने न प्रयोजयेत् ॥ ३४॥ (का० सं० क० २)

३. वर्जयेद्विद्वलानि विदहीनि गुल्फि च । अन्त्यानि सोष्णक्षीराणि गुर्विणानां विवर्जयेत् ॥ ६॥

मृत्तिका भक्षणीया न च सूर्यकन्दकाः । रसेनश्च पातलाडुश्च सन्त्याज्यो गुर्विणीसिध्या ॥ ७॥

सूर्याणि प्रदेयानि गौल्यानि सरसानि च ॥ ८॥

व्यायामं मैथुनं तेषां शोषं चक्रमणं तथा । वर्जयेद्गुर्विणीनाञ्च जायते सुखसम्पदः ॥ ९॥ (हा० सं० तृतीय ४९)

पाठ में शोष शब्द अत्र है जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता सम्भवतः यहाँ पर "शोक" शब्द होना चाहिए।

ऊपर शोक ही अर्थ लिया गया है।

४. गर्भिणी न तु कुर्वीत व्यायाममपवर्णम् । व्यायामं च न सेवेत न कुर्यादतिवर्णम् ॥ ३३२॥

यत्रो जग्राणं शोकं यानस्यारोहणं तथा । रक्तमोक्षं वेगरोषं न कुर्यादुत्कटसन्म ॥ ३३३॥

मलिनं विवृणक्तं होतुर्हो न स्मृशतिव्यम् । न जिघ्रेदीप दुर्गन्धं न परशेन्नयनाप्रियम् ॥ ३३४॥

वर्जयेत् नापि शृणुयात्कणयोपिवाणि च । नात्रं पुसीधतं शुष्कं भुञ्जीत क्रथितं न च ॥ ३३५॥

चैत्यमश्रावृक्षश्च भवांश्चाप्यशस्करान् । बहिर्निष्क्रमणं क्रोधं शूयान्गारं च वर्जयेत् ॥ ३३७॥

नैवेद्यैश्च तत्कुपयधेन गर्भो विनश्यति । तौलाप्यङ्गोद्भूतं च नाल्यर्थं कारयेदपि ॥ ३३८॥

नाग्रासराणं कुर्यान्नित्यञ्च शयनसन्म । एतान्सु नियमासर्वाभ्यान्कुर्वीत गर्भिणी ॥ ३३९॥ (पा० प्र० पूर्व० ३)

होना बताया है एवं स्पष्टीकरण दिया है कि गर्भ की स्थिति होने के दिन से दूसरे मास में अथवा गर्भ की स्थिति का अतिशय होने पर या यथोक्त नक्षत्र आदि के न मिल सकने के कारण तीसरे मास में पुंसवन-संस्कार हो चुकने के बाद गर्भिणी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। पुंसवन संस्कार के बाद के लिए व्यास का मत है वह गर्भिणी स्त्री नदी के तीर पर जाना, आकाश (वर्षा या प्राकृतिक जलशायों) का जल पीना, पति की शैय्या पर सोना, मरी हुई सन्तान वाली स्त्रियों का साथ, देवाल्य तथा बगीचे में जाना तथा मांस-भोजन का त्याग कर दे।

योगरत्नकरकर ने गर्भिणी स्त्री को र्वेदन, वमन, क्षार का प्रयोग एवं दूधित तथा विषम अन्न के सेवन आदि का निषेध किया है।

सभी आचार्यों ने गर्भिणी स्त्री को विभिन्न शोथन कर्मों का निषेध किया है। विनका गर्भिणी-व्य-चिकित्सानर्तक उल्लेख है।

Caraka says that the pregnant woman should avoid use of pungent things, (excessive) exercise and coitus, Following factors are harmful for the fetus such as—use of excessive heavy, hot and pungent substances; harsh or violent activities (activities much beyond one's own capacity) and others as instructed by elder persons, she should not wear red garments for protection from the effect of gods, demons and their followers; should not use intoxicating substances and wine, ride over vehicle (running on uneven path), use meat (excessive) and give up the things contrary to *indriyas* and other harmful articles; the things should also be given up as instructed by old ladies.

Sūśruta has mentioned that from the day of conception the woman should totally give up coitus, exercise, excessive satiation (*santāpāna* or anabolism), excessive emaciation (*apatāpāna* or catabolism), sleeping in day and awakening in night, grief, riding on vehicle, fear, squatting or the posture of sitting on the hams with the soles of feet touching the ground (*utkatakāśana*), and avoid untimely use of *snehana* (oleation), blood letting and suppression of natural urges. The coitus troubles the fetus. She should not touch dirty or disfigured persons possessing less body parts; should give up foul smelling, awful looking substances and exciting stories; should not eat dried up, stale, purified or wet (moistened) food. She should avoid outing, visit of lonely place, *chaitrya* (haunted tree), cremation ground or shade of a tree, acts likely to promote anger and disgrace, talking in high pitch etc. all the things likely to harm the fetus. Repeated excessive massage of oil and unguents should not be done, and she should not fatigue herself.

Vāgbhata I has corroborated the views of Caraka, however, alike Sūśruta he has also given the list of contraindications as—coitus, exercise, emaciation, trauma, conveyance i.e. carriage or animals causing excessive jerks, night awakening, day sleeping, suppression of

१. गर्भिणी ॥ ३०१॥ गर्भिण्यां गर्भपीडा ॥ ३०५॥

गर्भिणी गर्भवासदिवसत् द्वितीये मासि गर्भस्थितेतिश्च यथोक्तनक्षत्रादित्यापचने वा तृतीये मासि पुंसवनं कृते नाभिगच्छेत् । यत्रो पुंसवनान्तरमाह व्यासः—

तत्सत्यजेनतीरं देवखलोदकं तथा । भर्तुः शय्यां मूलपत्रां तथैवाभिषभोजनम् ॥

आभिषस्यशनं यत्नरामल परिजयेत् । देवानामनदीयानं प्रयोगं पुरश्च स च ॥ (पा० प्र० पूर्व० ५/३०१, ३०५, ३०६)

२. र्वेदनं वमनं क्षारं कर्तव्यं विषमशनम् । अपथ्यमिन्द्रमुद्दिष्टं गुर्विणीनां महर्षिभिः ॥ (यो० २० क्षीरोषोचि०)

natural urges, indigestion, prolonged stay in hot sun or near fire, anger, grief, fear, terror, fasting, squatting or other abnormal hard postures, falling in pits or wells, looking or hearing disliked things etc. The parents specially woman desirous of having offspring of high quality should make themselves superior. In first month massage of oil and unguents and upto fifth month use of articles likely to aggravate *doṣas* should be avoided.

Vagbhata II has also contraindicated besides excessive coitus and exercise others as carrying of heavy weight, covering herself with heavy sheet etc. untimely sleep, squatting or abnormal sitting, grief, anger, fear, excitement, suppression of desires and urges, fasting, or excessive walking, use of pungent, hot, heavy and *viṣamāhī* (hard to digest) food, use of red garments, peeping in a pit or well, use of wine or meat, sleeping in supine position etc. Blood letting, purifying measures (*śodhana* during whole pregnancy period) and enemas upto eighth month should not be used.

Kāśyapa has given entirely different type of contraindications i. e. she should not look at declining moon, setting sun and both the *rāhus* (*rāhu* and *ketu*). Knowing solar or lunar eclipse, she should go in the middle of house and perform religious rites and offer oblation to free the planets from the clutches of *grahas*. She should not have spite with guests, offer alms to beggars instead of turning them out, perform oblation of *ghṛta* in burning fire for pacification, should not oppose full ewer, *ghṛta*, garland and pot filled with *ghṛta* or curd, should not tie anything from thread or thin rope and loosen her all the bonds or wear very loose garments. She should not remain for long in acutely erect or flexed posture and carry heavy weight for long. avoid remeering, excessive laughing and trauma etc. Use of cold water and garlic is also contraindicated.

Hārīta has contraindicated use of pulses, edibles producing burning sensation (in abdomen), heavy or sour substances, hot milk, clay, *sirāṇa*, garlic and onion. *Sirāṇa* and other conspuating edibles should be taken with their juices. She should avoid coitus, exercise, anger, grief and walking etc. Avoidance of all these measures gives happiness to the woman.

Bhāvamiśra has followed Sūśruta with addition of sitting or sleeping in very soft and high place, going to river bank, temple or garden, drinking of rain water, use of meal, association of woman whose child has died etc. in the list of contraindications.

Yogarūpnākara has contraindicated use of sudation, emesis, *kṣāra* (alkalies) alongwith polluted and incompatible food.

Cleansing measures are contraindicated for pregnant woman.

विमर्श (Comments)

पूर्वग्रहों में लिखित विषय को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि आचार्यों ने गर्भिणी के लिए मुख्यतः निम्न प्रकार के निषेध बताए हैं (१) वे निषेध जो स्त्री में शारीरिक या मानसिक थकान या उत्तेजना उत्पन्न करें जैसे व्यायाम, व्यायाम, के निषेध बताए हैं (१) वे निषेध जो स्त्री में शारीरिक या मानसिक थकान या उत्तेजना उत्पन्न करें जैसे व्यायाम, व्यायाम, शोक, क्रोध आदि। यद्यपि सामान्य व्यायाम एवं व्यायाम गर्भिणी के लिए हानिकारक न हो लाभदायक होते हैं परन्तु यहाँ अत्यधिक व्यायाम, व्यायाम आदि का निषेध है जो शारीरिक या मानसिक थकान या उत्तेजना उत्पन्न कर गर्भिणी के स्वास्थ्य

को प्रभावित कर संभवतः गर्भ को भी प्रभावित करें। (२) अन्य निषेध जैसे शूयगार, चैत्य वृक्ष, रम्यभान आदि में जाना, कुंवे में झूलना आदि सभी क्रियाएँ संभवतः स्त्री को भय आदि के कारण तीव्र एवं आकस्मिक मानसिक आघात पहुँचाकर गर्भसंवादि उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं। (३) विषम ज्ञान-वाहन-सेवन या अत्यधिक भार-वाहन से औदत्योय भार-वृद्धि हो गर्भाशय पर दबाव पड़कर गर्भसंवाय या वेदना आदि उत्पन्न हो सकती है। विषम या उल्कट आसन गर्भाशय में दबाव डालकर अथवा के रक्तसंवहन तथा देर तक उठाना-शयन गर्भाशय के रक्त सञ्चार को प्रभावित कर गर्भाशयान्तर गर्भ को मृत्यु या अन्य उपद्रव कर सकते हैं। (४) कुछ निषेध भोजन आदि से सम्बन्धित हैं स्वाभाविक है कि विषम आदि अन्न का सेवन गर्भिणी स्त्री एवं परिणाम स्वरूप गर्भ के पोषण एवं वृद्धि को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर मांस का निषेध है जब कि चतुर्थ मास आदि में मलर्षि सुष्ठु ने जाड़ल मांस का विधान वर्णन किया है अतः यहाँ पर आरूप आदि ग्रन्थियों के अत्यधिक मांस सेवन का निषेध मानना चाहिए। अल्प मात्रा में प्रयुक्त मद्य भी हानिकारक नहीं होगा परन्तु अत्यधिक मद्य का प्रयोग गर्भ के लिए हानिकारक होता है। हरीतकीहृत्ता-वर्णित द्विदल, लहसुन एवं प्याज के निषेध का निश्चित स्पष्टीकरण कठिन है। इन पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग अग्नि में विषमता उत्पन्न कर पाचन शक्ति को प्रभावित कर विबन्ध आदि का कारण हो सकता है संभवतः इसी कारण से इनका निषेध किया गया हो। (५) गर्भिणी स्त्री में अतिरक्षण का भी निषेध है क्योंकि गर्भिणी का अतिरक्षण गर्भ को भी प्रभावित कर उसे अतिरक्षित बना देगा जिससे प्रसव में कठिनाई हो सकती है, शर्करा (कार्बोहाइड्रेट) तथा प्रभुजिन (प्रोटीन) से युक्त पदार्थों का अतिसेवन गर्भसंवाय विषममता का सम्भाव्य कारण माना जाता है। (६) काश्यप संहिता-वर्णित सूर्य-चन्द्रादि दृश्य के विशिष्ट नियमों का निश्चित स्पष्टीकरण कठिन है पर संभव है कि इन ग्रहों से विशिष्ट-काल में निकलने वाली किरणों में कुछ गर्भ-विकृतिकारक प्रभाव होता हो। (७) सभी शोचन कर्म स्त्री-शरीर का क्षोभन करके गर्भसंवादि उपद्रव-कारक होने की सम्भावना के ही कारण संभवतः निषिद्ध है।

All these contraindications can be grouped under following headings:

- 1) Those which produce psychological or physical strain such as grief, exercise etc.: Though normal coitus and exercise are beneficial, however, their excessive use or psychological trauma may precipitate abortion specially in ladies prone for the same.
- 2) Avoidance of visit to cremation ground etc: Sudden shock may produce abnormality specially abortion.
- 3) Over weight carrying or vehicle riding may precipitate abortion due to sudden increase in intraabdominal pressure; prolonged squatting in abnormal postures and supine position may influence placental and uterine blood flow (due to pressure of gravid uterus on iliac vessels) thus cause abortion, intrauterine death of the fetus or other abnormalities.
- 4) Dietetic regulations: Diet of pregnant mother is very important for maintenance of her own health, proper nourishment and growth of the fetus. Texts have contraindicated use of meat, while it is already advised by Sūśruta in fourth and fifth month, thus here excessive use of meat of aquatic animals should be taken. Wine in little quantity is not harmful, its excessive use harms the fetus. It is difficult to explain contraindications for use of pulses, garlic and onion etc., it is just possible that their excess use may produce digestive abnormalities.
- 5) Use of over satiation may excessively increase the body weight of mother and fetus, over eating is one of the cause of pregnancy toxemia. Over weight of fetus may cause difficulty in labour.

- 6) Specific rays emitted during eclipse may produce abnormalities of fetus.
7) Emetics etc. purifying measures can also precipitate abortion due to reflex stimulation of the myometrium.

गर्भिणी के द्वारा विशुद्ध वर्ज्य आहार-विहार के सेवन का परिणाम (Effect of use of contraindicated things by pregnant woman)

गर्भोपघातकारिण्ये भवा भवति; तद्यथा-उक्तविषमकठिनसन्सेविन्या वातभूत्रपुरीषवेगानुपूर्यन्त्या दारुणानुचितव्याध्यामसेविन्यास्त्रीश्लेष्मणोष्णतिमात्रसेविन्याः प्रमिताशनसेविन्या गर्भो भ्रम्यतेऽन्तः कुक्षेः, अकाले वा संमने, शोथी वा भवति; तथाऽभिघातप्रपीडनैः श्वभृक्पुष्पप्रातदशवलेकैर्वाऽभीष्टां मातुः प्रातःकाले गर्भः; तथाऽतिमात्रसङ्क्षोभिषयनैर्यानेन, अपिघातिमात्रश्रवणैर्वा। प्रतोलानशाधिः पुनर्गर्भस्य नाभ्याश्रया नाडी कण्ठमनुवेष्टयति, विवृतशोथिनी चोन्मत्तं जनयति, अपमासिपुः पुनः कालिकलहशीला, व्यावयशीला तथाऽनुवेष्टयति, स्त्रैण वा, शोकादित्या भूतिमपचितमल्लययुषं वा, अभिघातौ परोपतापिनमोषु स्त्रैण वा, स्तेना दुर्बलपुष्पमूर्हिकं स्त्रैण वा, शोकादित्या भूतिमपचितमल्लययुषं वा, स्वान्नित्या तन्त्रालुमुषधमल्लयानि वा, त्याग्यासबहुलमर्तद्वेहिणमकर्मशीलं वा, अमासिणी चण्डमौषधिकममयुषं वा स्वान्नित्या तन्त्रालुमुषधमल्लयानि वा, मद्यनित्या पिपासालुमुषधमल्लयानि वा, गोधामासप्राया शार्करिणमप्रीणं शनैर्महिणं वा, वराहमासप्राया मद्यनित्या अतिमपचितमल्लययुषं वा, मल्लयमांसनित्या चिरनिमेषं स्तब्धाक्षं वा, मधुरनित्या प्रमेहिणं मूकमतिस्थूलं वा, रत्नाक्षं क्रश्नमतिपक्वमोषाणं वा, मल्लयमांसनित्या चिरनिमेषं स्तब्धाक्षं वा, मधुरनित्या प्रमेहिणं मूकमतिस्थूलं वा, अस्त्वित्या रत्नाक्षिणी वा, लवणनित्या शीघ्रवलीपलितं खलित्यशोणिं वा, कटुकनित्या अस्त्वित्या रत्नाक्षिणी वा, लवणनित्या शीघ्रवलीपलितं खलित्यशोणिं वा, कटुकनित्या दुर्बलमल्लयशुकमनपल्यं वा, तिकित्या शोषिणमबलमनुपचितं वा, कषायनित्या श्यावमानाहिनमुद्रवर्तिनं वा, यद्यच्च यस्य व्याधेर्निदानमुक्तं तत्तदासेवमानाऽन्तर्वती तन्निमित्तविकारवहुलमपल्यं जनयति ॥ (च० सं० शा० ८/२१)

प्रतोलानशाधियाः पुनर्गर्भस्य नाभ्याश्रया नाडी कण्ठमनुवेष्टय व्यापति करोति। विवृतशया नक्तचाणिणी चोन्मत्तं जनयति। कलहशीलाऽपमासिपुः। व्यावयशीला दुर्बलपुष्पमूर्हिकं स्त्रैण वा। शोकादित्या भीरुमपचितमल्लययुषं वा। अभिघातिनी परोपतापिनमोषाणं स्त्रैण वा। स्तेना त्याग्यासबहुलमभिद्वेहिणमकर्मशीलं वा। अमप्राया चण्डमौषधिकं वा। स्वान्नशीला निद्रालुमुषधमल्लयानि वा। मद्यनित्या तुष्णालुमुषधमल्लयानि वा। गोधामासनित्याऽप्रीणं शनैर्महिणं वा। वराहमांसनित्या रत्नाक्षं क्रश्नमतिपक्वमोषाणं वा। मल्लयमांसनित्या चिरनिमेषं स्तब्धाक्षं वा। मधुरनित्या प्रमेहिणं मूकमतिस्थूलं वा। अस्त्वित्या रत्नाक्षिणी वा। लवणनित्या शीघ्रवलीपलितं खलितिकं वा। तिकित्या शोषिणमबलमपचितं वा। कटुकनित्या दुर्बलमल्लयशुकमनपल्यं वा। शीघ्रवलीपलितं खलितिकं वा। तिकित्या शोषिणमबलमपचितं वा। कटुकनित्या दुर्बलमल्लयशुकमनपल्यं वा। कषायनित्या श्यावमानाहिनमुद्रवर्तिनं वा। यच्च यस्य व्याधेर्निदानं तत्तदासेवमानाऽन्तर्वती स्त्री तत्तद्विकारवहुलमपल्यं जनयति। (अ० सं० शा० २/६१)

एभिर्गर्भः स्वदेहामः कुक्षौ शयुधेन्मिथेयत वा। (अ० शा० १/४७)

गर्भं का नाश करने वाली ये भाव होते हैं जैसे-उल्कट, कठिन एवं विषम आसन सेवन करने वाली; वात, मूत्र एवं पुरीष के वेग को रोकने वाली, दारुण एवं अनुचित व्यायाम सेवन करने वाली, तीक्ष्ण एवं उष्ण पदार्थों को अतिमात्रा में सेवन अथवा अल्प भोजन करने वाली स्त्री का गर्भ कुक्षि के अन्तर्गत ही मर जाता है या अकाल में ही गिर जाता है (गर्भस्राव या पात हो जाता है) या सूख जाता है। माता को (गर्भिणी के गर्भाशय या अर्धोदर में) अभिघात या प्रपीडन होने, उसके गहरे गड़बड़े, जुबूँ या प्रपात के स्थान को अत्यधिक देखने से गर्भ अकाल में ही गिर जाता है, इसी प्रकार अत्यधिक संक्षोभन उत्पन्न करने वाली सवर्णियों में यात्रा करने से या अप्रिय बात को अत्यधिक सुनने से भी (गर्भ का अकाल-पात) होता है। हाथ-पैर फैलाकर उत्तान शयन करने वाली स्त्री के गर्भ की नाभि-आश्रित नाड़ी कण्ठ में घूमने और लिपट कर कष्ट देती है। विवृत या अनवृत होकर या अनवृत देश (स्थान) में शयन करने वाली या रात में घूमने

वाली स्त्री उन्मत्त या उन्माद युक्त (पक्षसों आदि के प्रभाव के कारण) संतान को उत्पन्न करती है। कलि (बचन से झगड़ा) या कलह (शरीर से झगड़ा) करने वाली स्त्री अपस्मार से पीड़ित सन्तान को; अत्यधिक मैथुन करने वाली स्त्री निकुल शरीर वाली, निर्लज्ज एवं स्त्रैण (स्त्री के वशीभूत रहने वाली) सन्तान को; निन्दार शोक युक्त रहने वाली डरपोक, क्रुश, अल्पायु सन्तान को; अभिघातौ (मानसिक द्रोह करने वाली) स्त्री दूसरे को दुष्ट देने वाली, ईर्ष्यालु तथा स्त्रैण संतान को; चोरी करने वाली (गर्भावस्था में) स्त्री परिश्रमी, अतिबोही, अकर्मशील या काम न करने वाली संतान को; असहन्शील (किसी को बात को न सहने वाली गर्भिणी स्त्री) चण्ड, कपटी एवं परनिन्दक संतान को; अत्यधिक सोने वाली स्त्री तन्त्रालु, अज्ञानी या मूर्ख तथा अल्पायु संतान को; नित्य मद्य का सेवन करने वाली स्त्री पिपासालु, अल्पमृति एवं अस्थिरचित्त संतान को; अस्मर गोधा का मांस खाने वाली शर्करा, अश्रमी या शनैर्मह से पीड़ित सन्तान को; अस्मर सूकर का मांस खाने वाली रत्नाक्ष, क्रश्न (अचानक श्वासवरोध सदृश से युक्त) तथा अत्यधिक खुरदरे रोम वाली सन्तान को; नित्य मल्लय का मांस खाने वाली चिरनिमेषी (देर के बाद पलक झपकाने वाली) या स्तब्धाक्ष सन्तान को; नित्य मधुर (दुध को छोड़कर अन्य मधुर रस के द्रव्य अत्यधिक मात्रा में) खाने वाली प्रमेह युक्त, अतिस्थूल या मूक सन्तान को; नित्य (अत्यधिक) अल्प सेवन करने वाली रत्नाक्षिणी पीडित, लवक या अक्षिरोग पीडित सन्तान को; नित्य (अत्यधिक) लवण (रस) सेवन करने वाली शीघ्र वली (त्वचा की झुर्रियाँ), पलित (बाल पक जाना) या खलित (बाल झड़ना) रोग से पीड़ित सन्तान को; नित्य (अत्यधिक) कटु (रस) सेवन करने वाली दुर्बल, अल्प शुक्र वाली एवं अनपल्य (बन्ध्य) सन्तान को; नित्य तिक (रस के पदार्थ) सेवन करने वाली शोषरोग से पीड़ित, बलहीन एवं दुर्बल शरीर वाली सन्तान को; नित्य कषाय (रस के पदार्थ) सेवन करने वाली श्याव वर्ण, अनाह एवं उदरवर्ती पीडित संतान को जन्म देती है। व्याधियों के विशेष कारणभूत पदार्थों का सेवन करने से उस व्याधि सम्बन्धी विकारयुक्त सन्तान को उत्पन्न करती है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने अक्षरशः महर्षि चरक का अनुगमन किया है इन्होंने भी लिखा है कि प्रतोलान-शाधिनी-स्त्री के गर्भ की नाभि आश्रित नाड़ी कण्ठ का अनुवेष्टन कर कष्ट उत्पन्न करती है। अनवृत-मुष्ण शयन करने वाली या रात में घूमनेवाली उन्मत्त सन्तान को जन्म देती है। कलहशील स्त्री अपस्मार पीडित सन्तान को; व्यावयशील स्त्री अत्यधिक आलस्य करने वाली, निर्लज्ज एवं स्त्रैण सन्तान को; नित्य दुर्बली रहने वाली डरपोक, अपचित (स्वल्प भोग के योग्य शरीर वाली) एवं अल्पायु सन्तान को; नाग चिन्ता करने वाली परोपतापी, ईर्ष्यालु एवं स्त्रैण सन्तान को; चोरी करने वाली कठिन परिश्रमी, अतिबोही एवं अकर्मशील सन्तान को; असहन्शील स्त्री चण्ड एवं कपटी सन्तान को; अत्यधिक सोने वाली स्त्री निद्रालु, मूर्ख एवं अल्पानि सन्तान को; नित्य मद्य-सेवी स्त्री तुष्णालु, अल्पमृति युक्त एवं अस्थिर-चित्त सन्तान को; नित्य गोधा मांस सेवी स्त्री अश्रमी एवं शनैर्मह पीडित सन्तान को; नित्य सूकर मांस सेवी स्त्री लाल आँखों वाली, सोते समय नासिका से शब्द करने वाली, अति रक्ष रोगों के शरीर वाली सन्तान को; नित्य मल्लय मांस सेवी चिरनिमेषी एवं स्तब्धाक्ष सन्तान को; नित्य मधुर (रस के पदार्थ) सेवी स्त्री प्रमेह रोग से पीडित, अतिस्थूल एवं गुंभी सन्तान को; नित्य अम्ल (रस के पदार्थ) सेवन करने वाली स्त्री रत्नाक्षिणी रोग से या त्वचा या आँख के रोग से पीडित सन्तान को; नित्य लवण (रस के पदार्थ) सेवन करने वाली स्त्री वली, पलित एवं खलित से शीघ्र ही पीडित होने वाली सन्तान को; नित्य तिक (रस के पदार्थ) सेवन करने वाली स्त्री शोफी, निर्बल एवं अपचित सन्तान को; नित्य कटु (रस के पदार्थ) सेवन करने वाली

1. विवृते अनवृते देशे शयनशीला विवृतशाधिनी, विवृतशाधिनी तथा नक्तछाणिनी च रक्षःप्रभृतिभूताभिप्रायना भवति; तदाश्च भूतैर्भिभूतो गर्भ उन्मत्तो भवतीति युक्तम्। कलिः वाचिकः, कलहस्तु शारीरिकः। अभिघातौ मानसा द्रोहणशीला। औपचारिकं शाठ्यवाचिणम्। क्रश्नम् अकस्मान्दृष्टुसावरोधः।। मधुरनित्येह गर्भिणीवर्हित क्षीरं विहायान्यभ्युपयुजेतिनी बोद्धव्या; क्षीरस्य तु विहातवेन प्राशस्त्यम् ॥ (च० सं० शा० ८/२१ की चक्र० टी०)

2. विवृतशया विवृतानना या शेते दुर्बलपुष्पमलसप्रायम्, अपचितं स्वल्पभोगशरीरम्, अभिघातिनी नामाचिन्ताशीला क्रश्नो यः सुप्तो नासया शब्दं करोति ॥ (अ० सं० शा० २/६१ की इट्टु टी०)

स्त्री दुर्बल, अल्प-शुक्र एवं अनपत्य सन्तान को; नित्य कषाय (रस रं द्रव्य) सेवी स्त्री श्याम वर्ण, आनाह या उदावर्त पीडित सन्तान को जन्म देती है। गर्भिणी स्त्री जिस-जिस व्याधि के उत्पन्न कारणभूत पदार्थों का संतन करती है अधिकंश उन्हीं विकारों से युक्त सन्तान उत्पन्न होती है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने संक्षेप में वर्णन करते हुए लिखा है कि इनके द्वारा (गर्भोपपातकर भावों से) या तो आम गर्भ का स्राव हो जाता है या कुश्लि में ही गर्भ शुक्र हो जाता है या मर जाता है।

The effect of various dietetics etc. has been elaborately described by Caraka and Vāgbhata I which is given here under:

Dietetics or mode of life	Effect on the fetus or child
1* Squatting or sitting in abnormal position; suppression of urge of defecation, urination or flatus; improper and excessive exercise; use of pungent, hot edibles or less quantity of food.	Intrauterine death of fetus or premature delivery or abortion or fetus becomes dry (<i>upāsūkā</i> -missed abortion).
2* Trauma and compression (in lower abdomen), peeping or falling in deep pit or well, riding in jerking vehicle, listening to unpleasant words.	Premature delivery or abortion.
3 Sleeping in supine position with stretched extremities.	Umbilical cord encircles the neck of the fetus and troubles it.
4 Sleeping uncovered in open place or night walking.	Insane or extravagant (<i>unnatta</i>).
5. Oral and physical strife or pug-nacious.	Epileptic (<i>apasmāra</i>).
6. Over indulgence in sex.	Deformed, impudent or lazy and hen-pecked
7. Always distressed or grieved.	Poltroon, slender, short lived or less digestive etc. power.
8. Psychologically malevolent or constantly worried.	Nature of troubling others, jealous and henpecked.
9. Thief or robber.	Industrious, spiteful, idle.

cont.

Dietetics or mode of life	Effect on the fetus or child
10. Inolherent.	Furious, deceitful, insidious, calumnious.
11. Over sleepy.	Sleepy, ignorant and possess less digestive power
12. Using wine daily.	Over thirsty, short memory and flicking mind.
13. Often use of meat of iguana.	Suffers from bladder stone, gravel or slow stream of urine (<i>śanṛimeha</i>).
14. Often using hog's meat (pork).	Red eyes, rough body hair and obstructed breathing or snoring.
15. Using daily fish.	Fixed eyes or delayed blinking of eye lids.
16. Daily (excessive) use of sweet articles except milk.	Suffers from <i>pramēta</i> (urinary disorders including diabetes mellitus), obese and dumb.
17. Using (excessively) daily sour articles.	Suffers from <i>raktapitta</i> (bleeding diathesis), skin and eye disorders.
18. Daily (excessive) use of salty articles.	Early wrinkling, greying of hair and baldness.
19. Daily excessive use of bitter (<i>katu</i>) articles.	Weak, possess less quantity of <i>śukra</i> and infertile.
20. Daily excessive use of pungent (<i>tikta</i>) articles.	Suffers from emaciation (<i>śoṣa</i>) or edema (<i>śopha</i>), weak, scrappy and less digestive etc. powers.
21. Daily excessive use of astringent (<i>kaṣṭhā</i>) articles.	Swartly, suffers from <i>ānāha</i> (flautence) and <i>udārvata</i> (eructation).
22. Use of articles likely to produce diseases.	Diseases according to cause.

*Not mentioned by Vāgbhata I.

Vāgbhata II has just mentioned that use of articles likely to harm the fetus results either in abortion or intrauterine dryness or death (missed abortion or intrauterine death) of the fetus.

विमर्श (Comments)

महर्षि सुश्रुत ने गर्भोपपातकर भावों के अन्तर्गत इनका वर्णन नहीं किया, अतः अधिकंश रूप में सामञ्जस्य रखता हुआ वर्णन दौहद के अन्तर्गत आया है। वास्तविक रूप में दोनों ही वर्णनों में कोई विशिष्ट मतभेद नहीं है क्योंकि गर्भिणी

स्त्री अपने इच्छा होने पर ही उन पदार्थों का अत्यधिक सेवन करेगी जो कि दौहद के अन्तर्गत आता है, चूँकि ये विशिष्ट प्रयुक्त पदार्थ गर्भ में विकारोत्पादक हैं अतः महर्षि चरक आदि ने गर्भोपघातकर भावों के अन्तर्गत वर्णन किया है। परन्तु प्रभाव की दृष्टि से चरक एवं सुश्रुत दोनों ही आचार्यों में मत वैभिन्न है, चूँकि महर्षि सुश्रुत ने दौहद के परिणामों का वर्णन मांस प्रयोग तक ही सीमित किया है अतः केवल उन प्रयोगों का जिनमें दोनों ही आचार्यों ने लिखा है तुलनात्मक विवरण विषय के स्पष्टीकरण हेतु गोचे दिया जा रहा है।

प्रभाव (सन्तान में)		
खाद्य पदार्थ	सुश्रुत सं०	चरक सं०
गोधामांस	निद्रालु, धारणात्मक	शर्करा, अश्रुमत्, शर्माह पीड़ित
वगैरह मांस	स्वप्नलु, शूर	रक्तक्षि, क्रोधन युक्त

Suśruta has described almost similar things under the heading of *dauhrida* mentioned earlier. Actually there is no difference between these descriptions, because the pregnant woman will eat only when she has longing for these things, or has *dauhrida* and since these are likely to produce certain abnormalities in fetus, hence can be grouped under harmful category. Both these authors differ about the effect of meat of iguana and hog as given hereunder:

Effect on the child		
Edible	Suśruta S.	Caraka S.
Meat of iguana	Sleepy and the nature of bearing itself.	Suffers from gravel, bladder stone or slow stream of urine.
Meat of hog	drowsy, valient.	Red eyed, rough haired and obstructed breathing.

गर्भस्थापक औषधियाँ (Garbhashthapaka drugs i.e. the drugs beneficial for maintenance of pregnancy)

महर्षि चरक एवं काश्यप ने कतिपय औषधियों के प्रयोग का विधान बताया है। इन औषधियों के प्रयोगकाल का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। टीकाकार चक्रपाणि ने व्याख्या करते हुए लिखा है कि गर्भोपघातकर क्रियाओं द्वारा उत्पन्न गर्भोपघातक भाव का खण्डन कर जो पुनः गर्भस्थापन करें वे गर्भस्थापक औषधियाँ हैं। यह अर्थ लेने पर ये औषधियाँ गर्भस्राव की चिकित्सा के अन्तर्गत भी आ जाती हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने पुंसवन वर्णन के पश्चात् ही किसी विशिष्ट औषधि का नाम न लिखकर प्रजास्थापन महौषधि के प्रयोग का विधान दिया है। सूत्रस्थान में गर्भस्थापक औषधियों का वर्णन है, सम्भवतः यहाँ वे ही अभिप्रेत हैं। टीकाकार इन्द्र ने औषधियों का नामोल्लेख न कर इन्हें प्रतिशक्त्यपक औषधि के रूप में वर्णन किया है अर्थात् इनके प्रयोग से गर्भस्राव नहीं होता। महर्षि काश्यप ने इनके सामान्य प्रयोग का निर्देश किया है। सम्भवतः इन औषधियों का गर्भिणी द्वारा साधारणतया

१. संप्रति स्थितस्य गर्भस्य गर्भोपघातकभावप्रभावखण्डकत्वेन यत् पुनः स्थितिकारकं तद्गर्भस्थापनमुच्यते॥

(च० सं० शा० ८/२० की चक्र० टी०)

२. गर्भस्थापनानि धैर्मयो न खनन्ति॥ (अ० सं० शा० १/६२ की इन्द्र टी०)

प्रयोग गर्भ को सुस्थिर एवं सुपोषित करे, इस विचार के आधार पर ही इनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

ऐन्द्रीब्राह्मीशतवीर्यसहस्रवीर्यामोषाऽव्यधशिरिवाऽरिष्टावाट्यपुष्पीविष्वक्सेनकान्ता इति दशोमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति॥ (च० सं० सू० ४/१८ (४९))

अत ऊर्ध्वं गर्भस्थापनानि व्याख्यास्यामः—ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्यामोषाऽव्यधशिरिवाऽरिष्टा वाट्यपुष्पी विष्वक्सेनकान्ता चेत्सासामोषधीनां शिरसा दक्षिणेन वा पाणिना धारणम्, एताभिश्चैव सिद्धस्य पयसः सर्पिषो वा पानम्, एताभिश्चैव पुष्ये पुष्ये स्नानं, सदा च ताः समालभेत। तथा सर्वासं जीवनीयोक्तानामोषधीनां सदापयोग-स्तेस्तेरुपयोगविधिभिः। इति गर्भस्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति॥ (च० सं० शा० ८/२०)

ऐन्द्री दुर्वाऽमोषा विष्वक्सेनाऽव्यधशिरिवाऽरिष्टा।

ब्राह्मी सवाट्यपुष्पी शतवीर्या स्थापयेद्गर्भम्॥ (अ० सं० सू० १५/४८)

ततः प्रजास्थापनाख्या महौषधीः शिरसा दक्षिणेन च पाणिना धारयेत्। एताभिश्च सिद्धं पयो घृतं वा पिबेत्। एताभिरेव पुष्ये पुष्ये स्नायास्तदा चेत्समालभेत। तथा सर्वासं जीवनीयानामोषधीनां सदापयोगस्तैस्त्वैविधिभिः। इति गर्भस्थापनानि। (अ० सं० शा० १/६२)

बहुपुत्राभ्यन्तं च ईश्वरीं मुदितं तथा॥१७७॥

बार्हणी च सहदेवां च तथा चैवेन्द्रवारुणीम्। जीवकर्षभकौ भार्गी समङ्गां च तथैव च॥१७८॥

रोहपादान् वटशुङ्गानाम्गुप्तां तथैव च। अरिष्टं पूतनां केरीं शतवीर्यां च पार्थिवं॥१७९॥

सहस्रवीर्यां चैतानि प्रजापत्येन संहेता। संदधेदथ पुष्येण धारयेदुत्तरेषु च॥१८०॥

त्रैवृत्तं तु मणिं कृत्वा तं श्रोण्यां गर्भिणी सदा॥१८१॥ (का० सं० खि० १०)

ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या (दूवी), सहस्रवीर्या (दूवीभेद), अमोषा (पाटला, आमलकी या लस्मणा), अव्यधा (कदली, गुडूची, हरीकी), शिवा, अरिष्टा (कटुरोहिणी), वाट्यपुष्पी तथा विष्वक्सेनकान्ता (प्रियंगु) ये दश औषधियाँ प्रजास्थापन हैं।

महर्षि चरक ने पुनः इन्हीं औषधियों की पुनरावृत्ति करते हुए लिखा है कि अब इसके बाद गर्भस्थापक औषधियों की व्याख्या कर रहे हैं—ऐन्द्री (गोश्वकर्कटी), ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्रवीर्या (दुर्वाद्वय), अमोषा (पाटला), अव्यधा (गुडूची), शिवा, अरिष्टा (कटुरोहिणी), वाट्यपुष्पी (पीतवला), विष्वक्सेनकान्ता इन सभी औषधियों को शिर में या दक्षिण हाथ में धारण करे। इन्हीं औषधियों से साधित दुग्ध या घृत का पान करे। इन्हीं औषधियों (के क्वाथ से बने जल) से प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में स्नान करे। हर समय इन्हें पास रखे। इसी प्रकार इन्हीं उपर्युक्त विधियों से जीवनीय वर्ग की औषधियों का प्रयोग करे। यह गर्भस्थापन औषधियों की व्याख्या हो गई।

महर्षि वाग्भट ने महर्षि चरक का ही अनुगमन किया है उन्होंने भी लिखा है कि ऐन्द्री, दूर्वा, अमोषा, विष्वक्सेना, अव्यधा, शिवा, अरिष्टा, ब्राह्मी, वाट्यपुष्पी, शतवीर्या आदि द्रव्य गर्भस्थापन करते हैं।

इसके पश्चात् (पुंसवन कर्म के पश्चात्) प्रजास्थापन में वर्णित (उपर्युक्त) महौषधियों को शिर में एवं दाहिने हाथ में धारण करे। इन्हीं औषधियों से सिद्ध दुग्ध या घृत का पान करे। इन्हीं द्रव्यों से प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में स्नान करे तथा इन्हें हर समय पास में रखे तथा सभी जीवनीय गण को भी औषधियों को इन्हीं विधानों से प्रयोग करे। ये गर्भस्थापन हैं।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि हे पार्थिव ! (गर्भिणी स्त्री) बहुपुत्रा (काटकारी), अनन्ता, ईश्वरी, मुदितानि (शिवलिङ्गी), ब्राह्मी, सहदेवा, इन्द्रवारुणी, जीवक, ऋषभक, भार्गी, समङ्गा, रोहपाद, वटशुङ्ग, आत्मगुप्ता, अरिष्टा, पूतना,

१. कोष्ठक वर्णित औषधियाँ टीकाकार चक्रपाणि ने शरीरस्थान में लिखी हैं।

केसी (जटामर्सी), शतवीर्य, सहस्रवीर्य आदि औषधियों को प्रजापत्य विधि से उखाड़कर बाद में पुष्प नक्षत्र में धारण करें। निवृत की मणि बनकर गर्भिणी स्त्री कमर में हर समय बाँधे।

Caraka and Kāśyapa have prescribed certain drugs during pregnancy without specifying their indications, period or method of use. Cakrapāṇi has clarified that *garbhasāhāpana* drugs are those which after counteracting the effect of harmful factors (*garbhopagāhātakara bhāvās*) for fetus help in its proper maintenance, thus these can be considered even as a treatment for abortion.

Vāgbhata I has indicated use of *prajāśāhāpana* drugs described in *sūrasāhāna* after *janasāvana karma*. Indu says that these drugs prevent abortion.

Kāśyapa has advised these to be used as a routine by pregnant woman. Routine use of these drugs might be beneficial for maintenance of proper health, growth and development of mother and fetus respectively. With this idea the drugs are being enumerated here.

Caraka and Vāgbhata have enumerated *aindrī, brāhmī, śatavīryā, sahasravīryā* or *dūrā, amoghā, avyathā, śivā, arisā, vādyapuspī, viśwakṣenakāṭā* or *viśwakṣenā* in the list and have advised the oral use of milk or *ghṛta* prepared with these drugs. The bath with these drugs (cold decoction of these drugs) during *pusya nakṣatra* should also be taken. These drugs should also be kept in close contact of mother and amulets of these be tied in head or right arm (only Caraka). Similarly the drugs of *jyauṇya* group should also be used.

Kāśyapa has advocated that *bahupurā, anantā, īśvarī, muditā, brāhmī, sahadevī, indravīryā, jīvaka, ṛṣabhaka, bhāṅgu, samāṅgā, rohapāṇā, vata śūṅgā* (leaf bud), *āma-gupṭā, arisā, pūṭanā, keśī, śatavīryā* and *sahasravīryā* drugs should be uprooted with enchantation of *mantras* and tied as amulet during *pusya nakṣatra*. Amulet of *trivṛta* should also be tied in the waist of pregnant woman.



अध्याय ६

CHAPTER VI

गर्भिणी-व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा

(DISORDERS DURING PREGNANCY AND THEIR MANAGEMENT)

गर्भिणी स्त्री के शरीर में भी दोष वैषम्य के कारण वे सभी व्याधियाँ हो सकती हैं जो किसी भी व्यक्ति के शरीर या मन को पीड़ित करती हैं।

महर्षि काश्यप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्वर आदि विकारों के जो जो लक्षण अनाद वातक (पूर्ण वृद्ध युक्त वातक) के होते हैं, वे ही गर्भिणी स्त्री के भी समझने चाहिए। परन्तु गम्भीरता एक विशिष्ट अवस्था होने तथा तीक्ष्ण औषधियों आदि के प्रयोग से गर्भ को हानि पहुँचने की सम्भावना के कारण किसी भी व्याधि का चिकित्सा-सूत्र एक सोमा तक सामान्य अवस्था से भिन्न रहता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आचार्यों ने गर्भिणी की व्याधियों का सामान्य चिकित्सा-सूत्र दिया है एवं कुछ उन विशिष्ट व्याधियों का जो स्त्री को गम्भीरता में ही आक्रान्त करती हैं उल्लेख भी किया है। महर्षि काश्यप ने गर्भिणी की चिकित्सा की उपदेयता का वर्णन करते हुए लिखा है कि इससे गर्भ तथा गति दोनों की वृद्धि एवं रक्षा होती है।

महर्षि चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट आदि ने सामान्य चिकित्सा-सूत्र-वर्णन के साथ कुछ विशिष्ट व्याधियों का भी उल्लेख किया है। महर्षि काश्यप ने इस विषय पर सम्पूर्ण दो अध्याय (चि० स्थान का गर्भिणीचिकित्सा एवं खिलस्थान का अन्तर्वर्ती-चिकित्साध्याय) लिखे हैं। योगतन्त्रकारक एवं आचार्य भावमिश्र जी ने भी कुछ व्याधियों में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट औषधियों का नामोल्लेख किया है।

महर्षि हारात ने शोष, हृल्लस, छर्दि, शोफ, ज्वर, अलवि, अतिसार एवं विवर्णता आदि आठ गर्भोपद्रवों का उल्लेख किया है, जिन सभी की चिकित्सा का वर्णन अग्रिम पृष्ठों पर किया जायगा।

महर्षि सुश्रुत ने वातव्याधियों के अन्तर्गत गर्भिणी को आर्द्रित व्याधि (फेजेंट पैरिलिसिस) होने का उल्लेख किया है।

अर्थात् एवं शोफ के कारणों में गर्भ के द्वारा उत्पीड़न का उल्लेख महर्षि चरक एवं वाग्भट ने किया है। यह देखा जाता है कि गर्भ से वृद्ध गर्भाशय के द्वारा उत्पन्न अधोदर की सिराओं में दबाव से गर्भवती स्त्रियों को अर्थात् हो जाता है विशेषकर अर्ध पीड़ित स्त्रियों के लक्षण अत्यधिक बढ़ जाते हैं। यैयों की सिराओं में गर्भाशय का दबाव, पाण्डु या गर्भ-जन्य विषमयता में शोफ पाया जाता है।

१. ज्वराद्यानां विकाराणां यत्र यत्रैह लक्षणम् ॥ १८२॥

अनादानां प्रवक्ष्यामि तज्ज्ञेयं गर्भिणीव्याधि ॥ १८३॥ (का० सं० खि० १०)

२. सूक्ष्मां चिकित्सां वक्ष्यामि गर्भिणीनां विभागाशः। तथा गर्भश्च गति च वर्षते रक्षयेऽपि च ॥ (का० सं० खि० १०/३)

३. शोषो हृल्लसच्छर्दिश्च शोफो ज्वरस्तथाश्विः। अतिसारो विवर्णत्वमप्यै गर्भस्योपद्रवाः ॥ (हा० सं० तृतीयस्थान ५/११)

४. गर्भिणीसूतिका। अर्धपित्वाऽनिली। (सु० सं० नि० १६/८, ६५)

५. च० सं० नि० १४/९; अ० सं० नि० ७/१० एवं अ० ह० नि० ७/१४

६. च० सं० सू० १८/६; अ० सं० नि० १३/१८, ३० एवं अ० ह० नि० १३/२६, ३८

There is no difference in the physical or psychological disorders of a pregnant woman from any other individual, because *dysas* and *disyas* of the body are same, she also exhibits similar symptomatology of fever etc. disorders as noticed in any other grown up person. However, principles of treatment differ, because use of any pungent etc. drug is likely to harm the fetus. Considering this very fact the authors have advocated principles of treatment for a pregnant woman and have also given description of a few disorders afflicting the woman exclusively during pregnancy. Realizing the importance of the subject Kāśyapa has given two full chapters on this and has emphasized that proper management of disorders during pregnancy is helpful for protection and development of both mother and fetus. Hārta has enlisted *śosa* (emaciation), *hṛlāsa* (nausea), *chardi* (vomiting), *śōṭa* (edema), *jvara* (fever), *aruci* (anorexia), *atisāra* (diarrhoea) and *vivarnatā* (discolouration) etc. *eṣṭh* disorders which afflict the pregnant woman. Suśruta has included the pregnant woman also in the list of persons likely to suffer from *ardita* (facial paralysis). In the causes of piles and edema Caraka and Vāgbhata have included pressure caused by growing fetus also.

गर्भिणी की व्याधियों का सामान्य चिकित्सा सूत्र (General principles of treatment for pregnant woman)

व्याधौश्चास्या मृदुमधुरशिशिरसुखसुकुमारप्रायैरौषधाहारोपचारैरुपचरेत्, न चास्या वमनविरचनशिरविरचनानि प्रयोजयेत्, न रक्तमवसेचयेत्, सर्वकालं च नास्थपनमनुवासनं वा कुर्यादत्यत्रात्यधिकद्व्याधेः । अष्टमं मासमुपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारोच्चात्यधिकेषु मृदुभिर्वमनादिभिरुपचर्यकालिभर्वापचारः स्यात् । पूर्णमिव तैलपात्रमसंक्षेपयताऽनन्तर्वन्ति भवत्युपचर्या ॥ (च० सं० शा० ८/२२)

अथ गर्भिणीं व्याध्यस्तनात्वात्यये छर्देत्, मधुरास्तेनात्रोपहितेनानुलोमयेच्च, संशमनीयं च मृदु विदध्या-दन्नपात्रयोः, अशनीयाच्च मृदुवीर्यं मधुरप्रायं गर्भाधिकद्वं च, गर्भाधिकद्वं च, गर्भाधिकद्वं च, गर्भाधिकद्वं च विदधीत मृदुप्रायः ॥ (सु० सं० शा० १०/६७)

व्याधौश्चास्या मृदुमधुरशिशिरसुखसुकुमारप्रायैरौषधाहारोपचारैरुपचरेत् ॥ न चास्या वमनादीनि प्रयोजयेत् । न रक्तमवसेचनं केवलं त्वष्टमं मासमुपादायास्थपनमनुवासनं वा । वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारेषु मृदुभिस्तदर्थकालिभर्वापक्रमेत् । पूर्णमिव तैलपात्रसंक्षेपयताऽर्भिणीमुपाचरेदिति ॥ ६२ ॥

इत्यनात्ययिके व्याधौ विधितव्यधिके पुनः । तीक्ष्णैरपि क्रियायोगैः सिद्धं यत्नेन पातयेत् ॥ ६३ ॥
(अ० सं० शा० २/६२ च ६३)

व्याधौश्चास्या मृदुसुखंतीक्ष्णैरौषधैर्नयेत् ॥ (अ० ह० शा० १/४९)

इसकी (गर्भिणी स्त्री की) व्याधियों की (उन उन व्याधियों में प्रयुक्त) मृदु, मधुर, शीतवीर्य, सुखकारक एवं सुकुमार प्राय औषधियों तथा आहार एवं उपचार (व्यवहार विशेषतः सुकुमार एवं सुखकारक उपचार) आदि से चिकित्सा करे । इसे वमन, विरेचन एवं शिरविरचन आदि का प्रयोग न करवावे, रक्त का अवसेचन न करे । सर्वदा आस्थपन एवं अनुवासन बलित का प्रयोग न करे, यदि आत्ययिक व्याधि है (अर्थात् तीव्र व्याधि है जिसमें आस्थपन या अनुवासन अत्यवश्यक है) तो इनका (आस्थपन एवं अनुवासन का मृदु) प्रयोग कर सकते हैं । अष्टम मास प्राप्त हो जाने पर वमन आदि से साध्य विकारों में आत्ययिक अवस्था में मृदु वमन आदि से या तदर्थकारी उपचारों से चिकित्सा करें । तैल से पूर्ण पात्र के असंक्षेपन सदृश हो गर्भिणी की चिकित्सा की जाती है अर्थात् जिस प्रकार भरे हुए तैल पात्र का थोड़ा सा भी संक्षेपन

होने से तैल के गिर जाने का भय रहता है उसी प्रकार गर्भिणी स्त्री की असावधानी से चिकित्सा करने पर गर्भस्त्राव एवं गर्भपातदि का भय रहता है । टीकाकार चक्रपाणि ने वमनादि के तदर्थकारी शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, कि वमन के स्थान पर उसी भाँति का परिणाम देने के कारण निष्ठोवन एवं विरेचन के स्थान में फलवर्ति का प्रयोग करना चाहिए । अन्यत्र गर्भिणी के लिए तीक्ष्णैषध, व्यायाम एवं व्यवय को त्याग्य कहा है ।

महर्षि सुश्रुत ने भी लगभग महर्षि चरक के ही मत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि गर्भिणी को व्याधि उत्पन्न होने पर आत्ययिक अवस्था में अर्थात् व्याधि का जिनशकरी स्वरूप होने पर उसे वमन करवावे, तथा मधुर एवं अम्ल अन्न के साथ (मिली हुई औषधि से) अनुलोमन भी करावे । सभी संशमनीय द्रव्य मृदु वीर्य के तथा अन्नपान के साथ मिलकर दे । वह मृदुवीर्य मधुरप्राय एवं गर्भ को हानि न करने वाला भोजन करे । गर्भ के अकिरुद्ध या हानि न करने वाले विहार के प्रयोग का भी विधान बताया है, तथा यथायोग्य क्रिया से वमनादि के हीन, अति या मिथ्यायोग से विरहित अर्थात् सम्पक् प्रयोग का निर्देश किया है ।

अष्टांगसंग्रहकार ने महर्षि चरक का अक्षरशः पालन करते हुए लिखा है कि गर्भिणी स्त्री की व्याधियों की मृदु, मधुर, शिशिर एवं सुखकारी औषधियों तथा आहार एवं विहार से चिकित्सा करनी चाहिए । वमनादि का प्रयोग तथा रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए । अष्टम मास से (आठवें मास का एक भी दिन लगा जाने पर प्रसवकाल तक आवश्यकता होने पर दोषानुसार) आस्थपन एवं अनुवासन बलित का प्रयोग करना चाहिए । वमनादि से ही साध्य विकारों की मृदु वमनादि से तथा उस व्याधि के लिए लाभदायक विरिष्ट औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए । तैल से पूर्ण पात्र के असंक्षेपन सदृश ही गर्भिणी स्त्री की सावधानी से चिकित्सा करे । टीकाकार इन्द्र ने लिखा है कि वमनादि साध्य व्याधियों में भी वमन का प्रयोग नहीं करना चाहिए । अन्यत्र भी महर्षि चरक सदृश ही तीक्ष्णैषध प्रयोग, व्यायाम एवं व्यवय को गर्भिणी के लिए वर्ज्य माना है । उपर्युक्त चिकित्सा सिद्धान्त सामान्य आत्ययिक व्याधि के लिए है, आत्ययिक अवस्था में तीक्ष्ण आदि क्रियाओं के प्रयोग के द्वारा भी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए (अर्थात् स्त्री के जीवन रक्षण गर्भ की उपेक्षा ककरे भी तीक्ष्ण आदि क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए) ।

अष्टांगहृदयकार ने संक्षिप्त रूप में लिखा है कि इसकी (गर्भिणी की) व्याधियों की मृदु, सुखकार एवं अतीक्ष्ण औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए ।

१. तदर्थकालिभर्वाति यथा वमनार्थकारी निष्ठोवनं, विरेचनार्थकारिणी फलवर्तिः, इत्यादिभिरुपचारः कर्तव्यः ।
(च० सं० शा० ८/२२ की चक्र० टी०)
२.गर्भिणी तीक्ष्णैषधव्यायामवर्जनीयानाम् ॥ (च० सं० सू० २५/४०)
३.अत्यये विनाशहेती ॥ (सु० सं० शा० १०/६७ की डल्ल० टी०)
४. 'छर्देत्' को पृथक् न कर यदि मधुर के साथ अर्थात् 'छर्देन्मधुर' आदि का ग्रहण क्रिया जाय तो वमनौषधियों को भी मधुर एवं अम्ल अन्न के साथ ही मिलकर प्रयोग करने का निर्देश मिलता है ।
५. विशारयस्य नियमयकाह-गर्भाधिकद्वं इत्यादि यथायोग्यमहीनातिमिथ्यायोगोनेत्यर्थः ॥
(सु० सं० शा० १०/६७ की डल्ल० टी०)
६. वमनादीनि कर्माप्यस्या व्याधिवशात् प्रसक्तान्यपि न प्रयोजयेत् । केवलमष्टममासप्रथमद्विमासद्वयप्रसववदौषाद्यपेक्षया आस्थपनमनुवासनं वा प्रयोजयेत् व्याधुपशममर्थं यत् करोति तदर्थकारि ।
(अ० सं० शा० २/६२ की इन्द्र टी०)
७. अ० सं० सू० १३/३

महर्षि हारीत ने सामान्य चिकित्सा वर्णन करते हुए लिखा है कि वत्सक, पिप्पली, शुण्ठी, आमलकी-फल तथा कोमल कित्वा अर्थात् कच्चे बेल की गिरी को दधि के साथ पीसकर शर्करा मिलाकर पिलाना सर्वत्र हितकर है, तथा विद्वान वैद्य को गर्भिणी स्त्री को कभी भी तीव्र विरेचन नहीं देना चाहिए।

Caraka opines that the diseases of pregnant woman should be treated with the use of soft, sweet, cold, pleasing and gentle drugs, dietetics and behaviour. She should not be given emetics, purgatives or suberthines (sternutatory drugs), bloodletting, should not be used *Āsthāpāna* and *anuvasāna basties* (cleansing and nutritive enemas) should not be done. After eighth frequently, however, if the disorder is acute, moderate use of these can be done. After eighth month the diseases curable by emetics etc. should be treated with gentle emesis etc. or such other procedures which give similar benefits, such as instead of emetics or purgatives the drugs causing spitting or suppositories respectively should be used. Use of pungent drugs, exercise and coitus should be avoided. The pregnant woman should be treated just like a pot filled with oil, as slightest oscillation of such pot causes spilling of oil, similarly slightest excitement to the pregnant woman can initiate abortion etc.

Suśruta has advised that if the disease is acute and/or serious, emetics should be given followed by use of sweet and sour edibles mixed with *anulomaka* (carminative) drugs. All the pacifying drugs should be soft and be given alongwith food or drinks. Diet should consist of the article which are soft, sweet and harmless to the fetus. Appropriate use (neither too less, nor excessive nor abnormal) of such gentle emetics etc. purifying measures should be done which are congenial to the fetus.

Vāgbhata corroborating the views of Caraka adds that if the disease is very serious, the life of woman should be saved by use of drastic measures and pungent drugs (even if those are harmful to the fetus).

Hārīta has advised use of *vaṣṭaka*, *pīpplā*, *śunṭhī* and fruit of *āmalakī*. Unripe fruit of *bilva* mixed with curd and sugar is always beneficial. The pregnant woman should never be given drastic purgatives.

गर्भिणी की विशिष्ट व्याधियाँ एवं चिकित्सा (Specific diseases of pregnant woman and their treatment)

(अ) गर्भावस्था के विभिन्न मासों में उत्पन्न विशिष्ट व्याधियों के चिकित्सा-सूत्र (Principles of treatment of the diseases developing in different gestational months)

(१) चतुर्थ मास में वात-रोग चिकित्सा (Treatment of disorders of vāta during fourth month of pregnancy)

चतुर्थे मासि ॥ १४७॥

१. वत्सकं माषा शुण्ठी तथा चामलकीफलम् । युक्तं कोमलकित्वा च दद्यात् पिष्टं तु दण्डयेत् ॥ ४॥

शर्करासंयुतं पानं स्त्रीणां गर्भे हितं सदा ॥ ५॥

न दातव्यो मतिमत्ता विरेको दाहणो महान् ॥ १३/२॥ (हो० सं० तु० स्था० ५१)

एण्डपत्र (तैल-शु० पा०) क्षीरेण वातारोगान्विता भिद्येत् । वातमूत्रविरोधे तु शूलं चार्ज्य समुत्थिये ॥ १५१॥ (का० सं० छि० १०)

चतुर्थ मास में यदि गर्भिणी को कोई वातिक रोग, वातिक मूत्रग्रह या शूल हो तो एण्डपत्र (तैल) को क्षीर के साथ (पत्र-चूर्ण या तैल एवं क्षीर अथवा पत्र-चूर्ण-साधित क्षीर) पीने को दें ।

(एण्ड के तैल का प्रयोग वात के रोगों में वर्णित है न कि पत्र का, अतः यहाँ पर पत्र के स्थान पर तैल का पाठ आधिक उचित प्रतीत होता है) ।

If in fourth month of pregnancy the woman suffers from any disorder of vāta, retention of urine due to vāta and other pain etc. then *eraṇḍa talā* (castor oil) with milk should be given.

(२) पञ्चम मास में चिकित्सा-सूत्र (Principles of treatment in fifth month)

पञ्चमे मासि गर्भिण्या व्यक्तमस्तलवणं ततः । आस्थपनं हितं नार्यं मधुरं चानुवासनम् ॥ १५२॥ (का० सं० छि० १०)

पाँचवें मास में (व्याधि होने पर आवश्यकतानुसार) गर्भिणी को अम्ल एवं तवण द्रव्यों से युक्त आस्थापन तथा मधुर द्रव्यों से युक्त अनुवासन बतिस हितकर होती है ।

In fifth month she should be given *āsthāpāna basti* (evacuative enema) containing sour and salish drugs and *anuvasāna basti* (nutritive enema) containing sweet substances.

(३) षष्ठ मास में कतिपय व्याधियों की चिकित्सा (Principles of treatment of some diseases in sixth month)

ग्रन्थीनां पिडिकानां च शोथे चैव विशाम्यते ॥ रोहिण्यां विद्वधौ वाडपि षष्ठमासे विशेषतः ॥ यथास्त्वं भेषजं कुर्याद्वारुणं शास्त्रपाताः ॥ १५३॥ (का० सं० छि० १०)

है राजन् ! शाल-कुशल चिकित्सक को द्रव्ये मास में विशेषतः ग्रन्थि, पिडिका, शोथ, रोहिणी एवं विद्वधि होने पर रोग के अनुसार दारुण चिकित्सा (क्षारीन या शस्त्र कर्म) करनी चाहिए ।

During sixth month specially in cases of *granthi* (lymphadenitis), *piḍikā* (tumor-cysts), *śoṭha* (inflammation), *rohini* (pseudomembrane of throat) and *vidvadhī* (abscess), *dāruṇa-ckikita* (harsh or rough treatment i.e. use of *kṣāra*, cauterization and surgery) should be done by wise physician.

(४) सप्तम मास में कतिपय व्याधियों का चिकित्सा-सूत्र (Principles of treatment of few disorders during seventh month)

पीनमांसोपशमनं क्षारकामिनिकर्मच । भग्नस्थिश्चेष्टेण चैव शस्त्रकर्म तथैव च ॥ १५४॥ सप्तमेमासि नारीणां सर्वभेदेन प्रयोजयेत् ॥ १५५॥ (का० सं० छि० १०)

सप्तम मास में गर्भिणी स्त्री में उन्नत मांस का शमन (तीक्ष्ण द्रव्यों या शस्त्रकर्म द्वारा), क्षार एवं अग्नि कर्म, भग्न अस्थि का संधान तथा शस्त्रकर्म आदि सभी प्रकार के कर्म प्रयुक्त करने चाहिए ।

In seventh month suppression of protuberant flesh (treatment of mole, cysts etc. by drugs or surgical measures), use of *kṣāra* and cauterization, reduction of fractured bone and other surgical treatment should be done.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह अर्थ निकालना कि सातवें मास के पूर्व अस्थिसंघान गगनचक्रम करना ही नहीं चाहिए, युक्तिसंगत नहीं होगा; क्योंकि अस्थिघन होने पर तात्कालिक संघान आवश्यक है। सातवें मास के पूर्व संघानादि कर्मों के करने के साथ गर्भस्थापक द्रव्यों का प्रयोग भी अभिप्रेत है, क्योंकि वेदना से मार्मिक प्रभाव होकर गर्भस्थाव या पाल का भय रहता है, परन्तु सातवें मास के बाद इस प्रकार का प्रतिरोधक औषध-प्रयोग आवश्यक नहीं है।

It appears from above description that reduction of fractures or other surgery should not be done before seventh month which is not logical, because the reduction of fracture has to be done immediately. However, along with reduction certain drugs/sedatives to prevent abortion should always be given, because pain and psychological stress due to trauma can initiate abortion. This preventive treatment is not needed after seventh month.

(आ) गर्भिणी को ही होने वाली व्याधियाँ (Pregnancy-disorders)

(१) गर्भज वमन (Vomiting during pregnancy)

व्याकगर्भा के अन्तर्गत छर्दि का वर्णन लक्षण-स्वरूप सभी आयुर्वेदिक संहिताओं में मिलता है। सद्योगहीतगर्भा के लक्षणों में मुखप्रसेक, ह्रस्वस आदि का भी उल्लेख है। महर्षि सुश्रुत ने छर्दि के अनेक कारणों के अन्तर्गत आक्त्रसत्वा होना या गर्भिणी होना भी एक कारण माना है। पुनश्च छर्दि के पञ्चम भेद में वीभत्स, कृमि आदि के ही साथ दौहद का भी उल्लेख किया है। जिसके स्मृतीकरण में टीकाकार डल्लण ने दौहद के अवमग्न से या गर्भिणीमित्र से उत्पन्न छर्दि को दौहदका माना है। इसी भाँति वाग्भट ने भी मलिन, दुर्गन्धित आदि पदार्थों के देखने या सुनने से, चित्त दुःखी या हृत्पथ के पीड़ित होने से उत्पन्न द्विद्वार्षजा छर्दि का उल्लेख कर दौहद को भी एक कारण माना है। माधवचिन्ता के मधुकोष व्याख्याकार ने लिखा है कि गर्भ से उत्तीव्र होने के कारण विकृत वायु ही दौहद जन्य वमन का कारण है। भावमिश्र, योगरत्नाकर आदि ने आगन्तुज छर्दि के कारणों में दौहद का भी उल्लेख किया है। मर्षी आचार्यों ने इस छर्दि में भी दोषानुसार विवेचन करने का निर्देश किया है, अर्थात् यह स्पष्ट हो जाता है कि यह छर्दि-वर्णन सामान्य लक्षण स्वरूप उत्पन्न छर्दि (मॉर्निंग सिमिस) का न होकर वैकालिक छर्दि (हाइड्रोमोसिस ग्रेविडेस) का वर्णन है; अतः इसकी सम्प्रति तथा चिकित्सा-सिद्धान्त सामान्य छर्दि के ही सदृश होंगे।

१. नार्वाध्यापनसत्वायाः॥ ४॥

वोभत्सजा दौहदकाऽऽमजा च।

सा पञ्चमी तां च विभावयेत् तु दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥ १२॥ (सु० सं० उ० ४९/४, १२)

२. दौहदका दौहदविमानाज्जाला, अन्ये दौहदजां गर्भिनिमामाहुः (सु० सं० उ० ४९/४२ की डल्ल० टी०)

३. पूर्यमेध्याशुचिद्विद्वद्वर्गप्रवणादिभिः।

तो चित्ते हृदि हित्स्ते छर्दिद्विद्वार्षयोगजा।

वातादीनेव विप्रशुक्लमिदृग्णाऽऽमदौहरे ॥ (अ० सं० नि० ५/३८ व ३९, अ० ह० नि० ५/३६ व ३७)

४. नार्वाध्यापनसत्वाया इति गर्भिण्याः, तस्या गर्भात्सीडेने वातवैयुष्यच्छर्दिः। (मा० नि० १५/३ की मधु० व्या०)

५. (अ) ... दौहदका च या हि।

सा पञ्चमी ताञ्च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ। (मा० प्र० चि० १७/११)

(आ) नार्वाध्यापनसत्वाया। (मा० नि० १५/३)

वोभत्सजा दौहदकाऽऽमजा च।

(३) सा पञ्चमी तां च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ। (मा० नि० १५/१२; यो० २० छर्दि० नि०)

गर्भिणी-व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा

उपर्युक्त वर्णित विषय का अवलोकन करने पर गर्भज वमन के निम्न तीन कारण स्पष्ट होते हैं।

All the classics have mentioned excessive salivation and nausea etc. as symptoms of normal pregnancy. In the description of disease *charḍi* Suśruta has enlisted pregnancy also as a causative factor. Under its fifth type i. e. *āgūṇya* or *dviśāṭhāja charḍi* the *dauhrida* is also enumerated in etiology. Dahanā has explained that non fulfilment of *dauhrida* and presence of fetus cause vomiting. In Madhukosa commentary it is mentioned that *vāṇ* being pushed upward by fetus gets provoked and causes vomiting. For its management assessment of relative predominance of various *doṣas* should be made. This statement clearly indicates that this description is aimed at mentioning disease hyperemesis gravidarum having etopathogenesis identical to general *charḍi*. Above mentioned etopathogenesis clarifies three specific causes for this hyperemesis gravidarum:

(१) वात-वैयुष्य (Vata-vāyūṣya)

वायुदोष नाडीवह संस्थान का द्योतक है, अतः इसकी विगुणता से स्त्री की संज्ञावह नाड़ियों के कार्य में विगुणता आकर विपरीत प्रत्यावर्तन (रिफ्लेक्स फ़ैक्ट) हो वमन हो सकता है, अथवा स्त्री की मानसिक स्थिति (इमोशनेल या सहकोजोनेक फ़ैक्ट) में विकार हो वमन हो सकता है।

Vāta denotes nervous system including psychology of individual. Abnormality of this may initiate vomiting by exaggerated or abnormal reflex action or in other words this heading indicates reflex and psychogenic factors as causation of hyperemesis.

(२) दौहद अवमग्न (Dauhrida avamāgna or non fulfilment of dauhrida)

स्त्री को अधिकांशतया दौहद उन चीजों का होता है जिनकी शरीर में कमी होती है। दौहद की अपूर्ति से उस कमी के कारण का अन्तर्भाव कर सकते हैं।

Normally the woman desires the substances for whom she is deficient. Nonfulfilment of these may produce certain deficiency and this may initiate vomiting.

(३) गर्भ निमित्त (Garbha nimitta or due to fetus)

जहाँ गर्भावस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण ज्ञात न हो अर्थात् ट्रोफोब्लास्ट द्वारा निर्मित अंगरसों के प्रति स्त्री द्वारा प्रतिक्रिया जन्य अथवा अज्ञात कारणजन्य।

Where in except existence of pregnancy there is no other demonstrable cause, thus vomiting occurs either due to immune response of woman for trophoblastic hormones or idiopathic.

महर्षि काश्यप ने अन्तर्वर्त्तीचिकित्साध्याय में विभिन्न दोषोत्पन्न छर्दि की चिकित्सा का वर्णन किया है, परन्तु दौहदजन्य या गर्भजन्य छर्दि की विशिष्ट चिकित्सा का उल्लेख नहीं किया। जिससे स्पष्ट होता है कि यह वर्णन गर्भिणी की विशिष्ट छर्दि (हाइड्रोमोसिस ग्रेविडेस) का न होकर गर्भावस्था में होने वाली अन्य कारणोत्पन्न छर्दि (असोशिएटेड वॉमिटिंग) का है।

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर गर्भिणी छर्दि का निम्न वर्गीकरण कर सकते हैं:-

(अ) लक्षणान्तर्गत वर्णित ह्रस्वस या मुखप्रसेक इमोसिस ग्रेविडेस या मॉर्निंग सिमिस

- (आ) दौहदजन्य छर्दि
(इ) दोषज छर्दि (काश्यप वर्णित)

हाइपेमेसिस ग्रेविडेस
अंसेरिण्टेड वॉमिटिंग

Kāśyapa has described management of *dosaja chardi* in *anarvānīkīśādhya* but has not referred to *dauhrdajanya* or *garbhajanya chardi*. Thus this seems to be description of associated vomiting. On the basis of above description vomiting during pregnancy can be termed in following way:

- | | |
|--|--|
| a) <i>Mukhaprasaka</i> or <i>hritasa</i> or <i>chardi</i> described as a symptom of pregnancy. | Emesis gravidarum or morning sickness. |
| b) <i>Dauhrdajanya chardi</i> | Hypertemesis gravidarum. |
| c) <i>Dosaja chardi</i> described by Kāśyapa | Associated vomiting during pregnancy. |

गर्भज वमन चिकित्सा (Treatment of vomiting during pregnancy)

गर्भज वमन के चिकित्सा-सिद्धान्त सामान्य छर्दि के सदृश ही होंगे, परन्तु गर्भावस्था के कारण वमन आदि शोथन कर्मों का निषेध होगा। औषधियों में भी पूर्वपुष्टों में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार मृदु, मधुर औषधियों का प्रयोग ही अपेक्ष्य है।

The principles of treatment are identical to general vomiting, however, purifying measures such as emetics etc. had to be avoided and drugs of sweet and soft nature are to be given.

(अ) चिकित्सा-सिद्धान्त (Principles of treatment)

दौहद जन्य वमन की चिकित्सा अनुकूल उपचार एवं अकार्शित वस्तु देकर करनी चाहिए अर्थात् गर्भिणी जिस फल, मेय, भक्ष्य या लेह्य की आकांक्षा करे वही उसे दे तो वमन नहीं होगा, या वातादि दोषों का विचार कर उस प्रकार की चिकित्सा करें^१।

Pregnancy vomiting should be treated by providing agreeable attendance and desired articles, in other words if the woman is given desired fruits, edibles, drinkables and lickables etc. she will not eject them, besides other management should be done considering relative dominance of different *dosas*.

(आ) औषधियाँ (Recipes)

(१) शुनिम्ब (चिरायता) के कल्क में समान मात्रा में शर्करा मिलाकर पीने से गर्भिणी की छर्दि का विनाश होता है^१।

१. (अ)..... दौहर्दि कांक्षितैः फलैः। (सु० ३० ४९/२५)
(आ) अनुकूलोपचारेण याति द्विष्टार्थका शमम् ॥ (अ० सं० चि० ८/१३ एवं अ० ह० चि० ६/२१)
(इ) इष्टदौहदजां फलैः। (पा० १० चि० १७/२८)
(ई) दौहदस्यां वामिं हृद्यैः कांक्षितैर्वस्तुभिर्बन्धेत् ॥ (यो० २० छर्दि० चि०)
२. दौहदजास्या यथास्वं वाताद्योषधेन च शमं याति। (अ० सं० चि० ८/१३ की इन्द्रु टी०)
३. पीतोपुनिम्बकल्कश्च शर्करासमभाविताः ॥ छर्दिं हरेत् ॥ (हो० सं० पु० स्या० ५१/१)

(२) शुण्ठी एवं बिल्व के क्वाथ में यव का सत्व मिलाकर पिलाने से गर्भिणी के छर्दि एवं अतिसार का नाश होता है^१।

(३) कुसुम्बरी (घान्क) के कल्क में तण्डुलोदक एवं शर्करा मिलाकर पीने से गर्भिणी की छर्दि का निवारण होता है^१।

(४) बिल्वमज्जा एवं लाजापत्र पीने से गर्भिणी छर्दि का शमन होता है^१।

- (i) Use of pestled *bhumibha* with equal quantity of sugar suppresses vomiting.
- (ii) Flour of parched barley mixed with decoction of *sunthi* and *bilva* cures diarrhoea and vomiting of pregnant woman.
- (iii) Paste of *dhanvaka* mixed with rice water and sugar cures pregnancy vomiting.
- (iv) Pulp of *bilva* fruit mixed with itiquid prepared from parched paddy relieves pregnancy vomiting.

(ई) दोष प्राधान्य के आधार पर गर्भिणी वमन-चिकित्सा (Treatment of vomiting during pregnancy according to dominance of doshas)

(१) वातज वमन-चिकित्सा (Treatment of vomiting due to vāta)

मातुलुङ्ग का रस, लाजा (घान का लावा), कोलमज्जा, अञ्जन (शुद्ध रसञ्जन), दाडिमसार (अनादना) एवं शर्करा तथा मधु के साथ बनाया हुआ लेह्य विशेषकर वातिक छर्दि का शमन करता है^३।

हे राजन्! अम्ल दाडिम के साथ पकाए हुए लवण विरहित मांसरस (अजा मांस) या माहिष मांसरस का सचिकर पदार्थों के साथ मिलाकर प्रयोग वातज छर्दि का नाशक होता है^३।

An electuary prepared with juice of *mātulunga* (lemon), parched paddy, kernel of *kola* (juniper), *anjana*, *dāḍimasāra* (seeds of pomegranate), sugar and honey cures vomiting due to *vāta*.

The salt fire soup prepared by cooking meal of goat or buffalo with sour pomegranate and mixed with appetizing articles cures vomiting due to *vāta*.

(२) पित्तज वमन-चिकित्सा (Treatment of vomiting due to pitta)

शर्करा एवं मधु से मिश्रित लाजा चूर्ण से युक्त तथा चतुर्जातक के कल्क से हृद्य बनाया हुआ, पुष्पों से सुवासित

१: शुण्ठीबिल्वकषाणं तु यवसकुसुमचिन्तम् ॥ ९॥
गर्भिणीं पापयेष्टैश्चछदीसारानशमम्।

कुसुम्बरीणां कल्कं तु तण्डुलोदकसंयुतम्।

पिनेत्सशर्करं हृद्यं गर्भिणीच्छर्दिनिवारणम् ॥ ११॥

बिल्वमज्जा च लाजापत्रं पिबेच्छर्दिषु गर्भिणी ॥ १२॥ (यो० २० स्त्री० से० चि०)

२. अथ छर्दिविकित्सां तु प्रोच्यमानां निबोधत। मातुलुङ्गसो लाजाः कोलमज्जा तथाऽञ्जनम् ॥ ११८॥

तथा दाडिमसारश्च शर्करा शोदमेव च। एष वातात्मिका छर्दिं हन्ति लेहो विशेषतः ॥ ११९॥

दाडिमसारो सः पक्वो हृद्यो लवणवन्धितः। वातच्छर्दिहरो राजन्! माहिषो वा सुसंस्कृतः ॥ १२०॥ का० सं० छि० १०)

तण्डुलोटक पित्तज अर्दि का प्रशमन करता है^१।

सिता एवं मधु से युक्त ताजा की पेया हितकारी होती है^१।

शर्करा द्वारा मधुर किया हुआ जोंगल पशु या पक्षियों का मांसरस पथ्य होता है^१।

Rice water mixed with sugar, honey, flour of parched paddy, made palatable or appetizing by mixture of pestled *cauryātaka* and incensed with flowers cures vomiting due to *pituita*.

A drink prepared from parched paddy mixed with honey and sugar is beneficial. Meat soup of wild animals or birds sweetened with sugar is congenial to the patients.

(३) रसैष्मिक वमन-चिकित्सा (Treatment of vomiting due to *slesma*)

आम एवं जामुन के कोमल पत्तों के शीतल द्राघ में मधु मिलाकर पिलाने से रसैष्मिक अर्दि का शमन होता है^३। अनादाने से साधित, लवण एवं स्नेह से युक्त मुद्गायूर भोजन में देना चाहिए यह हृद्य एवं छोर्द-विनाशक है^३।

The cooled decoction of tender leaves of mango and blackberry mixed with honey relieves vomiting due to *kapha*.

Soup of *mudga* (a kind of bean i. e. green gram) medicated with seeds of pomegranate and mixed with salt and heated butter is appetizer and relieves vomiting.

(४) सन्निपातज वमन-चिकित्सा (Treatment of vomiting due to all the three *dosas*)

सन्निपातज अर्दि में संसृष्ट अर्थात् तीनों दोषों की मिली जुली चिकित्सा करनी चाहिए^१।

In this disease combined treatment prescribed for all the three *dosas* should be done.

(५) कृमिज वमन-चिकित्सा (Treatment of vomiting due to parasites)

कृमिज वमन में पूर्ववर्णित (दोष प्राधान्य के आधार पर दोषानुसार) चिकित्सा करनी चाहिए^४। पुनर्नवामूल तथा भद्रदार (देवदार) के क्वाथ में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए^४।

In this condition the treatment should be prescribed according to the predominance of specific *dosas*. The decoction of root of *punarnava* and *bhadradanu* mixed with honey should be given.

१. शर्करामधुसंयुक्त ताजानुसमायुतम् । चातुर्जातककल्केन हृद्यं पुष्यैः सुवासितम् ॥ १२१॥
पित्तच्छदिप्रशमनं हितं तण्डुलपाने । हिला ताजामयी पेया सिताक्षौद्रेण संयुता ॥ १२२॥

जान्गलो वा रसः पथ्यः शर्करा मधुरीकृतः । (का० सं० वि० १०)

२. आम्रजम्बूफलानि सिताग्निं सुभृताग्निं तु ॥ १२३॥

क्षौद्रयुक्तानि पेयानि श्लेष्मच्छर्द्या विशेषतः । पोजनार्थं हितं यूथं मुद्गादिद्विमसामि(धि)नम् ॥ १२४॥
व्यपेतलेहलवणं हृद्यं छोर्दिनिशानम् ॥ १२५॥ (का० सं० वि० १०)

३. सन्निपात समुत्थायां संसृष्टान्यवचारयेत् ॥ १२५॥ (का० सं० वि० १०)

४. क्रिमिजायां तु कर्तव्यं यत् पुरस्तात् प्रवक्ष्यते । वर्षामूलानिकायां योजयेद्भद्रदारणाम् ॥ १२६॥ (का० सं० वि० १०)

(६) हृल्लास चिकित्सा (Treatment of nausea)

शूनिय कल्क का मधु के साथ प्रयोग हृक्लेद (जी मिचलाना) का शमन करता है^१।

Nausea is relieved by use of pestled *bhūnimba* with honey.

(२) किक्कस (Kikkisa or striae gravidarum)

निदान एवं लक्षण (Etiopathogenesis, signs and symptoms)

तत्र गर्भस्य केशा जायमाना मातृविदाहं जनयतीति स्त्रियो भाषन्ते; तत्रेति भगवानाश्रयेः, किन्तु गर्भास्तीड-नाद्वालपित्तश्लेष्माण उरः प्राप्य विदाहं जनयन्ति, ततः कण्डूरुपजायते कण्डूमूला च किक्किसावाभिर्भवति ॥

(च० सं० शा० ८/३२)

तस्मिंश्च गर्भस्य केशोत्पत्त्या मातृविदाहो भवतीति स्त्रियो भाषन्ते । नेति भगवानाश्रयेः । गर्भास्तीडनात् दोषा हृदयं प्राप्य विदहन्ति ततः कण्डूर्जायते कण्डूवा किक्किसम् ॥ (अ० सं० शा० ३/९)

गर्भोत्पत्तीद्विता दोषास्तीस्मिन् हृदयमाश्रिताः ।

कण्डू विदाहं कुर्वन्ति गर्भिण्या किक्किसानि च ॥ (अ० ह० शा० १/५८)

(इस सातवें मास में) गर्भ के केश उत्पन्न होने से माता को विदाह उत्पन्न होता है ऐसा स्त्रियाँ कहती हैं । भगवान आश्रय कहते हैं ऐसा नहीं है । गर्भ के कारण उत्पत्तीद्वित (गर्भ वृद्धि के कारण पीडित) वात, पित एवं कफ उत्पन्न को प्राप्त होकर विदाह उत्पन्न करते हैं, जिससे कण्डू उत्पन्न होती है, कण्डू के ही कारण किक्किस की उत्पत्ति होती है । टीकाकार चक्रवर्णि ने केशों की उत्पत्ति तृतीय मास से ही मानकर उन्हें कारणभूत नहीं माना तथा गर्भास्तीडन को ही कारणभूत होने का समर्थन किया है^१।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने महर्षि चरक सदृश वर्णन करते हुए केवल उरस् के स्थान में हृदय शब्द का प्रयोग किया है । टीकाकार इन्दु ने रेखा स्वरूप त्वक्-संकोच को किक्किस कहा है^३।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है, कि गर्भ से उत्पत्तीद्वित दोष हृदय में आश्रित होकर गर्भिणी में कण्डू, विदाह एवं किक्किस की उत्पत्ति कर देते हैं । टीकाकार अरुणदत्त ने विदाह से हाथ पैर का दाह तथा किक्किस से रेखासदृश आकृति के अतिरिक्त शूक के सदृश पूर्णता भी अर्थ किया है^४।

महर्षि भेल ने भी उपर्युक्त मत का ही प्रतिपादन किया है^५।

The women say that due to growth of scalp hair of the fetus in seventh month the mother gets *vidaha* (burning sensation) resulting into development of *kikkisa*, however, Ātreya says no, it is not so; the growing fetus displaces the *dosas* upwards, thus these *vāta*, *pituita* and *kapha* reaching *uras* (chest-Caraka) or *hridaya* (heart-Vāgbhaṭa) produce burning

१. पीते भूतिक्कलक्षः..... ।होच्च हृक्लेदं मधुना वा समन्वितः ॥ (हो० सं० तु० ५/१६)

२. च० सं० शा० ८/३२ की चक्रं टी० (पृष्ठ १५१)

३. रेखास्वरूपत्वसंकोचः किक्किसम् ॥ (अ० सं० शा० ३/९ की इन्दु टी०)

४. उरस्तनोरे बलिविशेषा रेखाकायास्तकारो प्रायो ये जायन्ते ते किक्किसलाः । कैशिराशूकानि पूर्णता किक्किसानि इति व्याख्यायि । पाणिपदासमूलेषु विविधः संतापः विदाह उच्यते (अ० ह० शा० १/५८ की असण० टी०)

५. समये तु खलु मासे गर्भप्रपीडिता वातपित्तश्लेष्माणो (ण) उरः प्राप्य विदह्यमाना कण्डू जनयन्ति । तेन किक्किसानि जायन्ते । (भै० सं० शा० ८/६)

sensation, which causes itching. The disease *kikisa* is the result of this itching. Cakrapāṇi opines that growth of hair can not be the cause as these start developing from third month itself. Indu says that linear contractions of skin are *kikisa*. Arunadatta has included burning sensation of palm and sole also as a symptom.

विमर्श (Comments) -

सप्तम मास के बाद गर्भ की वृद्धि के कारण उदर की त्वचा पर तनाव पड़ता है, एवं अन्य स्थानों जैसे स्तन, जंघा आदि में भी पुष्टि जन्म वृद्धि के कारण त्वचा में इसी प्रकार के तनाव से रेखाएँ बन जाती हैं, किक्किस (स्त्रावर्य ग्रेविडेस) नाम से उन्हीं का वर्णन प्रतीत होता है।

Seventh month onwards the uterus enlarged due to growing fetus and produces stretching of abdominal skin. Similarly development of various components of breasts cause stretching of skin. Due to this stretching linear lines appear over the skin of abdomen, breasts and thighs known as striae-gravidarum. *Kikisa* is description of this very condition.

चिकित्सा-चिकित्सा (Treatment) -

(१) मधुराण की औषधियों से साधित नवनीत को पाणितल मात्रा (२ तोले की मात्रा) में समय-समय पर गर्भिणी स्त्री को पीने को दे^{१,३}। बदरी (की त्वक्) के क्राय एवं मधुरौषध से सिद्ध नवनीत हितकारी है^३।

(२) निम्नांकित में से किसी एक से स्तन एवं उदर का मर्दन करें-
(अ) चन्दन एवं मृणाल^{१,३} अथवा चन्दन एवं उशीर का कल्क^३।

(आ) शिरीष (त्वक्), धातकी (पुष्प), सर्षप एवं मधुयष्टी का चूर्ण^{१,३}।

(इ) कुटज (त्वक्), अर्जक (बनजुलसी)-बीज, मुस्ता एवं हरिद्रा का कल्क^{१,३}।

(ई) निम्ब, बदरी, सुरसा (सभी के पत्र) एवं मंथिष का कल्क^{१,३}।

(उ) पुष्प (छोटे धब्बेदार पुष्प) या एण हरिण एवं शशक^{१,३} के रक्त से मिश्रित त्रिफला के कल्क^{१,३} से अथवा केवल शशक के रक्त में त्रिफला पीसकर^३।

(ऊ) शशक, हरिण (के रक्त), पुनर्नवा, मालती (पुष्प) एवं मधुयष्टी से सिद्ध जल^३।

(ए) करवीर^{१,३} एवं करञ्ज^३ के पत्तों के कल्क से साधित तैल से अभ्यास करें।

(३) निम्नांकित में किसी एक से स्तन एवं उदर का सिञ्चन करें-
(अ) पटोल, निम्ब, मंथिष एवं सुरसा का क्राय^३।

(आ) मालती (चमेली के पत्र एवं पुष्प) तथा मधुक से सिद्ध जल (क्राय)^{१,३}।

(इ) दाहरीद्रा एवं मधुक के क्राय से बार-बार मार्जन या प्रक्षालन करें।

(४) कण्डू होने पर भी त्वक्-भेद एवं वैरुष्य से बचाने के लिए कण्डू न करें^{१,३}। असह्य खुजली होने पर उपर्युक्त वर्णित चूर्ण आदि से मर्दन या वर्षण कर कण्डू का निवारण करें अथवा स्नान एवं उद्धर्तन में चन्दन के प्रयोग से शीतलता लायें, तलिक कण्डू न हो^३।

i) Butter treated with the drugs of *madhura* group should be given to pregnant woman frequently in the dose of *pāṇitāla mātra* (about 20 gms) or else the butter medicated with decoction of stem bark of *budari* (jujube) and drugs of *madhura* group should be given.

नोट- संदर्भ २५३ में देखें।

ii) Any one of the following should be rubbed over the abdomen and breasts :

a) The paste of *candana* and *mṛgāla* or *candana* and *uśīra*.

b) Powdered stem bark of *śīṛṣa*. Flowers of *dhātaki*, *sarsapa* and *madhupāṣi*.

c) Pestled bark of *kūja*, seeds of *arjaka*, *mustā* and *haridra*.

d) Pestled leaves of *nimba*, *budari* and *surasā* with *maṭiṣṭhā*.

e) *Triphala* pestled with the blood of *pṛṣata* or *eṇa* deer and rabbit or only *pṛṣata* deer or else *triphalā* pestled with the blood of rabbit.

f) Water medicated with *piṇṇavāra*, flowers of *mālaṭī* and *madhuka* and mixed with blood of deer and rabbit.

g) Oil prepared with pestled leaves of *karavīra* alone or with *karavīra*.

iii) Irrigation of abdomen and breasts should be done with decoction of either *piṭṭola*, *nimba*, *maṭiṣṭhā* and *surasā* or leaves and flowers of *mālaṭī* and *madhuka* or else repeated cleansing with decoction of *dāruharidra* and *madhuka* should be done.

iv) One should not scratch (in spite of urge for itching) to avoid disfigurement or skin stretching. If the itching becomes irresistible then above mentioned powders should be rubbed or anointment or bath should be taken with *candana* which will suppress itching sensation due to its coolness.

पथ्य (Beneficial diet)

मधुर, वातहर^१, थोड़ा-थोड़ा^३ (एवं बार-बार) अल्प स्नेह एवं लवण युक्त लघु आहार का सेवन करें, तथा अनुपान में थोड़े ही जल का प्रयोग करें (पथ्य में)^{१,३}।

The diet should be sweet, capable of suppressing *vāta*, either fat and salt free or with little quantity of fat and salt. Light and be taken repeatedly in small amounts followed by use of little quantity of water.

१. तत्र कोलोदकेन नवनीतस्य मधुरौषधसिद्धस्य पाणितलमात्रं काले काले रस्ते पात्रार्थं दद्यात्। चन्दनमृणालकल्कैश्च स्तनोदरं विमृदीयात्। शिरीषधातकीसर्षपमधुकचूर्णैर्वा, कुटजार्जकबीजमुस्ताहरिद्राकल्कैर्वा, निम्बकोलसुरसामंथिषकाकल्कैर्वा, पुष्पहरिण-शशलीधरयुक्ता त्रिफलया वा, करवीरपत्रसिद्धेन तैलेनाप्यङ्गः^३; परिषेकः पुनर्मालतीमधुकसिद्धेनाम्पसा; जातकण्डूश्च कण्डूयनं वर्द्धयेत्स्नानभेदे वैरुष्यपरिहारार्थम्, असह्यार्थं तु कण्डूयानुमर्दनीद्वर्षणार्थम् परिहारः स्यात्; मधुरमाहारजातं शुण्ठिपाणं वातहरमल्पमहेतुलवणमल्पोदकानुपानं च पुञ्जीत। (च० सं० शा० ८/३२)

२. तत्र कोलोदकेन नवनीतस्य मधुरौषधसिद्धस्य पाणितलमात्रमस्यै दद्यात्। चन्दनमृणालकल्कैश्च स्तनोदरं मृदीयात्। शिरीषधातकीसर्षपमधुकचूर्णैर्वा, कुटजार्जकबीजमुस्ताहरिद्राकल्कैर्वा, निम्बकोलसुरसामंथिषकाकल्कैर्वा, पुष्पहरिण-मालतीमधुकसिद्धेनाम्पसा वा शशलीधरयुक्ता त्रिफलया वा करवीरकाण्डपत्रकल्कसिद्धेन च तैलेनाप्यङ्गः^३। परिषेकः पुनर्मालतीमधुकसिद्धेनाम्पसा। कण्डूयनं वर्द्धयेत्। त्स्नानभेदे वैरुष्यपरिहारार्थं स्नानोद्धर्तनं च शीतयेत्। मधुरं चाहारमल्पमल्पमहेतुलवणमल्पोदकानुपानं पुञ्जीत॥ (अ० सं० शा० ३/१०)

३. नवनीतं हितं तत्र कोलायामधुरौषधैः। सिद्धमल्पमुदरेहं लघु स्वादु च भोजनम्॥ ५९॥

चन्दनीशारकल्केन तिमिरदुस्तनोदरम् श्रेष्ठया चैणहरीणशशीणितयुक्तया॥ ६०॥

अक्षयप्रसिद्धेन तैलेनाऽप्यङ्गं मदरेत्। पटोलनिम्बमंथिषासुतैः सेवयेत्तुः॥ ६१॥

दर्शिमधुकलोशनं मृज्वां च परिशीलयेत्॥ (अ० ह० शा० १)

४. स्त्रीणां (पुं) त्रिफलाचूर्णं शशलीधरेण पिष्ट्वा तेनास्याः तान्यालेपयेत्॥ (धे० सं० शा० ८/६)

(इ) अन्य व्याधियाँ (Other disorders during pregnancy)

(१) गर्भिणी-ज्वर (Fever of pregnant woman)

गर्भिणी-ज्वर चिकित्सा का महत्त्व (Importance of treatment of fever of a pregnant woman)

गर्भिणीनां ज्वरः कष्टः सर्वव्याधिषु पाथिवः ।

ज्वरोष्णपाशितससु गर्भो यात्येव चिकित्साम् ॥ ४॥

तस्माज्ज्वरचिकित्सां तु पूर्वमेव निबोध मे ॥ ५॥ (का० सं० छि० १०)

हे पाथिव ! गर्भिणी की व्याधियों में ज्वर सब व्याधियों से अधिक कष्टदायक होता है । ज्वर की उष्मा से अभिमत होने से गर्भ में भी विकृति आ जाती है अतः सर्वप्रथम मुझसे ज्वर की चिकित्सा जानो ।

The fever to a pregnant woman is most troublesome disease. The fetus also suffers due to transfer of heat of fever from mother to the fetus. Considering this, first of all fever is being described.

गर्भिणी-ज्वर-निदान (Diagnosis of fever of a pregnant woman)

क्षुब्धमाश्रयज्जाग्रीदृष्ट्यादौष्णयापववविधारणात् ॥ ५॥

स्नेहस्वेदैष्यनां च विप्रामातेजसोऽपि च । सत्तापान्मनसश्चापि पर्वतानां तथैव च ॥ ६॥

गन्धाच्च तृणपुष्पाणां गर्भिण्या जायते ज्वरः ॥ ७॥ (का० सं० छि० १०)

क्षुधा, श्रम, अपयजन, रक्षता, उष्णता, पक्व (मन) के घाण, स्नेहन एवं स्वेदन औषधियों तथा तेज (अग्नि) के विप्रम (मिथ्याज्ञा), मानसिक सत्ताप, पर्वतारोहण तथा तृण एवं पुष्पों की गन्ध से गर्भिणी स्त्री को ज्वर हो जाता है ।

Excessive hunger, exertion and massage, dryness, heat, retention of normal feces, improper use of oleatives, sudorifics and fire (heat), psychological strain, climbing on mountains and smell of grass and flowers (pollen) are the causative factors.

गर्भावस्था के चतुर्थमास से पूर्व ज्वर होने पर चिकित्सा-सूत्र (Principles of treatment of fever before 4th month of pregnancy)

गर्भिणीं चरितं नारीमेकाहमुपासयेत् ॥ ७॥

ततो दद्यादलवणां पेयां स्नेहविवर्जिताम् । तीक्ष्णानि त्वग्रथानि स्वेदमायासमेव च ॥ ८॥

वर्जयेज्ज्वरिता नारी यवाण् केवलं पिबेत् यवाया हुसिते दोषे यूषैरथानि दापयेत् ॥ ९॥

यूषैस्तु हुसिते दोषे रसं वा क्षीरमेव वा दापयेन्मतिमात्रं प्राज्ञो न तौषधविधिर्हितः ॥ १०॥

(का० सं० छि० १०)

(अग्निम पुष्टों में चतुर्थमासोपरंत दोषानुसार औषधि-प्रयोग का विधान वर्णित है अतः यह चिकित्सा-सूत्र चतुर्थ मास के पूर्व की गर्भ-स्थिति के समय का समझना चाहिए) ।

गर्भिणी को ज्वर होने पर एक दिन उपवास कराके लवण एवं स्नेह रहित पेया देनी चाहिए । ज्वर-पीड़ित गर्भिणी स्त्री को तीक्ष्ण अन्न-पात्र, स्वदेन एवं परिश्रम का परित्याग करना चाहिए तथा केवल यवाण् का पान करना चाहिए । बुद्धिमान

१. क्षुधा आदि सभी में पञ्चमी चिकित्सा होने के कारण उष्णता में पञ्चमी होना चाहिए अतः निम्न पाठान्त अधिक उपयुक्त प्रकृत होता है, "तैक्ष्ण्यौष्ण्यवच्छिन्नविधारणात्" यह पाठ करने पर अपक्व न होकर पक्व हो जायगा एवं मलधारण एक कारण होगा।

वैद्य को चाहिए कि यवाण्-पान से दोषों के घट जाने पर यूषों के साथ अन्न को दे । यूष-प्रयोग से दोषों के (और) घट जाने पर रस (मंसस) एवं क्षीर का प्रयोग करना चाहिए । औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

Before fourth month of pregnancy if woman suffers from fever, she should be advised to fast for one day, followed by use of drinkables free from fat and salt. Use of pungent dietetics and drinkables, sudorifics and exercise should be avoided. She should take only rice gruel. After subsidence of aggravated doshas by the use of rice gruel, the wise physician should prescribe her cereals with soups. With further subsidence of doshas by this procedure she should be advised meat soups and milk. No medicine should be given.

चतुर्थमासोपरंत ज्वर का चिकित्सा-सूत्र (Principles of treatment after 4th month)

अनुबन्धे तु दोषस्य गर्भकालमपेक्ष्य च । मासाच्चतुर्थार्धत् प्रभृति भिषगभेषजमाचरेत् ॥ ११॥

शरीरं तु ज्वरं ज्ञात्वा वातपित्तकफात्मकम् । मध्यां क्रियां प्रयुञ्जीत सञ्चिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ १२॥

उपद्रवबलं ज्ञात्वा सत्त्वं चापि समीक्ष्य तु । गर्भावस्थां तु विज्ञाय लेखनानि प्रदापयेत् ॥ १३॥

(का० सं० छि० १०)

चतुर्थमास एवं तत्पश्चात् गर्भावस्था के काल को देखकर दोषों के अनुबन्ध के अनुसार चिकित्सक को औषधियों का प्रयोग करना चाहिए । शरीर के वात, पित्त या कफात्मक ज्वर का ज्ञान करके, गुरुता एवं लघुता का (व्याधि की) विचार करके मध्यम क्रिया (अर्थात् न अधिक तीक्ष्ण, न मन्द, न उष्ण, न शीत, न अतिशोथनादि चिकित्सा) करनी चाहिए । उपद्रव, बल (रोग एवं रोगी का बल), सत्व (गर्भिणी का सत्व) एवं गर्भावस्था को देखकर लेखन आदि का प्रयोग करना चाहिए ।

During fourth month of pregnancy and later on the physician should prescribe the drugs after giving due consideration to the duration of pregnancy, amount of vitiation/ association of doshas. One should use moderate treatment after understanding the type of fever i. e. vāta, pitta or kapha jwara and also severity or mildness of disease. Use of lekhaṇa karma (the measures which make the body light) etc. should be done after considering properly the complications of disease, stemina and tolerance of the woman and her duration of pregnancy.

गर्भिणी को ज्वरावस्था में विभिन्न शोधन-कर्म-निषेध या शोधन का परिणाम (Effect of cleansing measures upon the pregnant woman during fever)

सभी आचार्यों ने सामान्य चिकित्सा-सूत्र वर्णन करते समय गर्भिणी को शोधन-कर्म का निषेध किया है, जो पूर्व पुष्टों में वर्णित है । इसके अतिरिक्त विभिन्न शोधन-कर्मों के अन्तर्गत भी गर्भिणी में इनके निषेध वर्णित हैं जैसे-स्नेहन-निषेध^१, स्वदेन-निषेध^२, वमन-निषेध^३, विरेचन-निषेध^४, सातवें-मास तक बलित-निषेध^५, नस्य-निषेध^६, धूम्रपान-

१. च० सं० सू० १३/५४ एवं का० सं० सू० २२/३०
२. च० सं० सू० १४/१६; सु० सं० चि० ३२/२५; अ० सं० सू० २६/३२; अ० ह० सू० १७/२४; का० सं० सू० २३/१६; भे० सं० सू० २३/१२ एवं शा० सं० उ० २/१३
३. च० सं० सि० २/८; सु० सं० चि० ३३/१५; अ० सं० सू० २७/७; अ० ह० सू० १८/३; का० सं० सि० ७/५; शा० सं० उ० ३/७; भे० सं० सू० २४/११ एवं भा० प्र० पूर्व द्वितीय भाग ५/७
४. च० सं० सि० २/११; सु० सं० चि० ३३/२३; अ० सं० सू० २७/८; शा० सं० उ० ४/७; भे० सं० सू० २४/११ एवं भा० प्र० पूर्व द्वितीय भाग ५/३९
५. सु० सं० चि० ३५/१३; अ० सं० सू० २८/११; अ० ह० सू० १९/६ एवं शा० सं० उ० ६/५
६. च० सं० सि० २/२०; सु० सं० चि० ४०/४७; अ० सं० सू० २९/११; का० सं० सि० ४/६ एवं शा० सं० उ० ८/४

निषेध^१, अग्निकर्म-निषेध^२, (महर्षि सुश्रुत ने अस्वेद्य को अग्निकर्म का भी निषेध किया है एवं गर्भिणी स्त्री अस्वेद्य है), क्षारकर्म-निषेध^३, तथा शिराविरचन-निषेध^४, अर्थात् गर्भिणी स्त्री को सामान्य रूप से सभी शोधन कर्मों का निषेध किया गया है। महर्षि चरक आदि ने गर्भिणी को शिराविरचन, वमन तथा विरेचन से होने वाली विविध व्याधियों का भी वर्णन किया है, जिनका यथा स्थान अग्रिम पृष्ठों पर उल्लेख किया जायगा। अन्य आचार्यों ने भी विभिन्न निषिद्ध व्यक्तियों में शोधन कर्मों से सामान्य व्याधियों के भी असाध्य हो जाने या मृत्यु होने का वर्णन किया है, पर इन निषिद्ध कर्मों का चक्र से कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है। ये सभी सामान्य रूप से गर्भिणी में करने के लिए निषिद्ध हैं, न कि किसी विशिष्ट अवस्था में। महर्षि काश्यप ने ज्वरावस्था में प्रयुक्त शोधन कर्मों से उत्पन्न उपद्रवों का वर्णन किया है। वर्णन की सुगमता एवं सम्पूर्ण विषय के एक स्थान में संकलन की दृष्टि से महर्षि चरक, वाग्भट एवं काश्यप आदि सभी के द्वारा वर्णित विषय एक साथ ही दिया जा रहा है। ज्वरार्त होने पर गर्भिणी स्त्री को अग्निकर्म, विष^५ प्रयोग तथा लंघन^६ निषिद्ध है।

All the authors have enlisted the state of pregnancy as one of the condition in which use of cleansing measures such as oleation, sudation, emesis, purgation, application of corrosive agents seventh month, inhalations (*nasayā*), smoking, cauterization, application of corrosive agents and venesection etc. are contraindicated. Caraka has described certain complications likely to occur in pregnant woman by use of stimulatory drugs, emetics and purgatives (described in subsequent pages). Other authors have also warned that use of these cleansing measures in the unfit persons can make their disease incurable or even cause death. All these contraindications are for pregnant woman in general, not specific to the febrile state, however, Kāśyapa has described certain complications of these various measures if applied during febrile state of pregnancy. Description of all these authors is given together in subsequent pages. Use of cauterization, *viṣa* (poisonous articles) and fasting is contraindicated to a febrile pregnant woman.

(अ) तरुण चक्र में अस्थि का परिणाम (*Effect of massage in acute fever*)

तरुणे तु च्चरे नार्या अस्थि न प्रशस्यते । गर्भे तु तरुणे दत्तो गर्भघाताय कल्पते ॥
(का० सं० चि० १०/१८)

तरुण (नवीन) चक्र में अस्थि नहीं देना चाहिए। गर्भावस्था के तरुण चक्र में दिया हुआ अस्थि गर्भ का घात कर देता है।

In fever of recent origin during pregnancy (*taruṇa jvara*) massage with oil should not be given, because it can kill the fetus.

१. सु० सं० चि० ४०/११
२. च० सं० चि० २५/१०५, सु० सं० सू० १२/१४
३. सु० सं० सू० ११/२८, अ० सं० सू० ३१/५, अ० ह० सू० ३०/६
४. सु० सं० सू० १४/२४, अ० सं० सू० ३६/८, अ० ह० सू० २७/०
५. अ० सं० सू० २७/८
६. च० सं० चि० २५/१०६
७. अ० सं० उ० ४८/११
८. भा० प्र० चि० १/०३

(आ१) नस्य-निषेध एवं परिणाम (*Effect of use of nasal drops or nasal pourings*)

गर्भिण्या हीनाङ्गस्य पथातोचकौ ॥ ६॥ (का० सं० सि० ४)
गर्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नाजुसेचयेत् । नस्यदनेन गर्भिण्याः प्राणस्तु परिहीयते ॥
(का० सं० सि० १०/१९)

गर्भिणी स्त्री को नासिका से अनुसेचन नहीं करना चाहिए अर्थात् नस्य नहीं देना चाहिए। नस्य देने से गर्भिणी स्त्री का गर्भ हीनाङ्ग वाला हो जाता है। गर्भिणी स्त्री अरोचक से पीड़ित होती है तथा उसकी प्राणशक्ति क्षीण होती है।

Nasal drops should not be prescribed to a pregnant woman or nothing should be poured into her nostrils because use of this produces less body-parts in the fetus, anorexia and reduces her vital capacity (*prāṇasakti*).

(आ२) नस्य से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा (*Treatment of complications of nasal therapy*)

..... गर्भिण्याश्च पुण्याध्याय (षाध्याय) येभ्योऽध्यायेभ्यो भेषजं विदध्यात् ॥ क्षीरं वा जीवनी-
योपसिद्धमिति परिचत् ॥ (का० सं० सि० ४/६, ७)

गर्भिणी को पुण्याध्याय या यूपध्याय आदि में वर्णित औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए विशेषकर जीवनी-द्रव्यों से सिद्ध द्रुप का प्रयोग करना चाहिए।

The drugs mentioned in *pūṣpādhyāya* and *yūpādhyāya* etc. should be prescribed, and milk treated with *Jivanyā* group of drugs should be given.

(इ) धूमपान-परिणाम (*Effect of smoking*)

कुणिर्वा यदि वाज्यश्च जायते दुर्बलैर्द्रव्यः । धूमपानेन गर्भिण्या धूमतेजोहतो भृशम् ॥ २०॥
विवर्णो जायते गर्भः पतद्वापि विशाम्यते ॥ २१॥ (का० सं० चि० १०)

हे राजन् ! गर्भिणी के धूमपान से, धूम के तेज से अत्यन्त आक्रान्त होने के कारण गर्भ (शिशु) कुणि (हाथ से पंज), अन्य, दुर्बलैर्द्रव्य या विवर्ण उत्पन्न होता है, या गर्भपात भी हो जाता है।

If the pregnant woman smokes, fetus effected severely by sharpness of smoke becomes crooked armed and blind, possesses weak cognitive and conative organs and abnormal complexion.

(ई१) शिराविरचन-परिणाम (*Effect of use of emetics or stimulatory drugs*)

गर्भिण्या गर्भं स्तभ्यते स काणः कुणिः पक्षहतः पीतसर्पी वा जायते ॥ (च० सं० सि० २/२१)
..... गर्भे वातो रूक्षेण नस्येन कुन्धः स्वाङ्जनयेददात् ॥ (च० सं० सि० १/११३)
गर्भिण्या भक्तद्वेषचरपूज्यार्थावभेदकाः स्युरापत्यं च व्यङ्गं विवर्तलैर्द्रव्यमुन्मादापसमारुहकं वा ॥
(अ० सं० सू० २९/११)

शिराविरके गर्भिण्याः संक्षेपानु भयेन वा ॥ २१॥
मारुतः कुणितो देहे गर्भघाताय कल्पते । अथवा वातरोगी तु गर्भो भवति पार्श्वि ॥ २२॥
(का० सं० चि० १०)

महर्षि चरक ने (सामान्य गर्भिणी को शिराविरचन देने से होने वाले परिणामों का वर्णन करते हुए) लिखा है कि

गर्भिणी को शिराविरचन देने से गर्भ का मन्मथन हो जाता है, वह काना, कुर्ण^१, पक्षाघात से पीड़ित तथा पुं^२ उत्पन्न होता है। रक्ष नस्य से वायु प्रकुण्ठित होकर अग्नं अनेक रोगों को उत्पन्न करती है।

महर्षि वाग्भट का कथन है कि गर्भिणी को नस्य देने से उसे भक्तदेष (भोजन से अस्वस्थि), ज्वर, मूर्च्छा एवं अर्धावभेदक (आंखें सन्निवृत्त), अर्धा व्याधिर्भूता हो जाती है एवं अपत्य व्यङ्ग्य, विकलेन्द्रिय, उन्माद एवं अपमान से पीड़ित हो जाता है।

महर्षि कारक्य ने (ज्वरित गर्भिणी को शिराविरचन देने के परिणामों का वर्णन करते हुए) लिखा है कि हे गर्भिणी ! गर्भिणी स्त्री को शिराविरचन देने में भय एवं संशय के कारण प्रकुण्ठित हुई वायु के द्वारा गर्भ का नाश हो जाता है अथवा गर्भ वातरोगी हो जाता है।

Caraka opines that use of sternutatory drugs by a pregnant woman (not necessarily during fever only) influences her fetus by making it stiff or immobile, besides the fetus becomes single eyed, crooked armed, hemiplegic, lame and suffers from various disorders of *vāta*. Vāgbhaṭa has enumerated anorexia, fever, unconsciousness and hemichorea to the woman and *vyāghra* (hyper pigmentation), abnormalities of *indriyas*, *apasmāra* (epilepsy) and *unmāda* (insanity) to the child.

Kāśyapa says that by use of sternutatory drugs during fever the *vāyu* gets aggravaated due to irritation and fear, this *vāyu* either kills the fetus or produces various disorders.

(ई२) शिराविरचन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा (Treatment for complications of sternutatory drugs)

तत्र वातहरः सर्वो विधिः स्नेहनबृंहणः।

स्नेहदिः, स्याद् घृतं क्षीरं गर्भियास्तु विशेषतः॥ (च० सं० सि० १/११४)

सभी वातहर विधि यथा स्नेहन, बृंहण एवं स्नेदन आदि करना चाहिए। गर्भिणी में विशेषकर घृत एवं क्षीर का प्रयोग करना चाहिए।

All the measures capable of suppressing the *vāta* such as oleation, *vr̥hṇa* (anabolic) and sudation should be applied. She should be given milk and *ghṛta*.

(उ) स्वेदन-परिणाम (Effect of sudation)

स्वेदेन तरुणे गर्भे पित्तं प्रकुण्ठितं भूषणं। व्यावदेदसु गर्भं तु तस्मात् स्वेदं विवर्जयेत्॥ २३॥

स्वेदः स्थिरे तु विहितो गर्भवैष्यवर्ककारकः॥ २४॥ (का० सं० छि० १०)

तरुण गर्भ में स्वेद देने से पित्त अत्यधिक प्रकुण्ठित होकर गर्भ को शोष गिरा देता है, अतः स्वेदन नहीं देना चाहिए। गर्भ के स्थिर होने पर स्वेदन गर्भ में विवर्णता कारक होता है।

If sudation is used in febrile condition during early pregnancy, the *pitṭa* gets severely vitiated and causes abortion, however after stability of fetus (4th month onwards) it produces abnormalities of complexion of the fetus.

(ऊ) वमन-परिणाम (Effect of emesis)

गर्भिण्या गर्भव्यापादमगर्भभ्रंशाच्च दारुणं रोगप्राप्तिः॥ (च० सं० सि० २/१)

१. कुर्णः कुञ्चितकरः, पीठसर्प पङ्क्तुः॥ (च० सं० सि० २/२१ की चक्र० टी०)

तत्र गर्भिण्या गर्भव्यापादमगर्भभ्रंशाच्च दारुणरोगप्राप्तिः स्यात्॥ (अ० सं० सू० २७/७)

वमनं तरुणे गर्भे स्वैर्गुणैर्गर्भघातकम्॥ २४॥ (का० सं० छि० १०)

महर्षि चरक एवं वाग्भट मतानुसार (सामान्य गर्भिणी को) वमन करने से गर्भव्यापद् एवं आम गर्भनाश तथा अन्य भयंकर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है।

महर्षि कारक्य-मतानुसार (ज्वर-पीड़ित गर्भिणी को) गर्भ की तरुणवस्था में वमन देने से वह (वमन) अपने गुणों के द्वारा गर्भ को नष्ट कर देता है।

Emesis given during pregnancy produces fetal abnormalities, abortion and other serious disorders is the opinion of Caraka and Vāgbhaṭa.

Kāśyapa writes that emesis to a febrile woman during early pregnancy destructs the fetus.

(ए) विरेचन-परिणाम (Effect of purgation)

गर्भिण्यन्तानां छर्दनेको दोषः स्यात्॥ (च० सं० सि० २/१२)

गर्भिण्यादीनां पूर्वोक्तदोषः स्यात्॥ (अ० सं० सू० २७/१०)

गर्भप्रपीडनोक्तानां संश्लेषाच्च विशेषतः। गर्भिण्यास्तरुणे गर्भे स्तंसनं न प्रशस्यते॥ २५॥

गुरुत्वादुष्णतीक्ष्णत्वाद्वाहनाच्चास्य घातकम्॥ २६॥ (का० सं० छि० १०)

महर्षि चरक एवं वाग्भट के मत से (सामान्य) गर्भिणी को विरेचन देने से वमनान्तर्गत वर्णित दोष हो होते हैं।

महर्षि कारक्य के मतानुसार (ज्वर से पीड़ित) गर्भिणी को गर्भ की तरुणवस्था में स्तंसन (विरेचन) (गर्भ को) नाभि के प्रपीडन करने विशेषतः संश्लेषन करने के कारण प्रशस्त नहीं माना गया है। यह गुरु, उष्ण, तीक्ष्ण तथा वाहन गुण के कारण गर्भ का घातक होता है।

Caraka and Vāgbhaṭa say that the abnormalities produced by purgation to a pregnant woman are similar to that of emesis.

Kāśyapa opines that as purgation produces compression of umbilicus and also irritation, hence it is not advised to a febrile woman of recent pregnancy. The purgation due to its heavy, hot and pungent qualities and the character of excessive mobility is harmful to the fetus.

(ऐ) आस्थापन एवं अनुवासन का परिणाम (Effect of evacuative and nutritive enemias)

गर्भिण्या पूर्वोक्तो दोषः॥ (अ० सं० सू० २८/११)

आस्थापनं तु तरुणे गर्भे नार्था न शस्यते॥ २६॥

अनुवासनं च मतमानिति शास्त्रविनिश्चयः। आस्थापनं सानुवासं करोति स्वेन तेजसा॥ २७॥

हीनाङ्गं स्वाविणं वाऽपि गर्भान्देष निश्चयः। तस्मादेतानि मतान् गर्भिण्या न प्रदापयेत्॥ २८॥

(का० सं० छि० १०)

गर्भिणी में पूर्वोक्त अर्थात् वमनान्तर्गत वर्णित आमगर्भ-भ्रंश आदि उपद्रव होते हैं।

शास्त्र निश्चय के अनुसार तरुण गर्भ में गर्भिणी (ज्वर-पीड़ित) को आस्थापन एवं अनुवासन दोनों ही प्रशस्त नहीं माने गए हैं। आस्थापन या अनुवासन देने से उसके तेज के कारण निश्चय ही गर्भ या तो हीनान्ग वाला हो जाता है या

१. गर्भिण्या आस्थापनेन पूर्वोक्तो वमनोक्तो आमगर्भभ्रंशादिः॥ (अ० सं० सू० २८/११ की इन्दु टी०)

उसका साव हो जाता है। अतः बुद्धिमान् वैद्य गर्भिणी स्त्री को ये (नम्य, श्लेष्मिन्निचन तथा अपस्थानानुवासन आदि) नहीं देते।

Both the types i. e. evacuative and nutritive enemias are not advisable to a pregnant woman, because these will produce the complications enlisted under enemias is the opinion of Vagbhata. Kāśyapa says that to a febrile woman of recent pregnancy if both these enemias are given, then fetus influenced by sharpness of these enemias either will possess less body parts or will get aborted.

गर्भिणी-ञ्चर की सामान्य चिकित्सा (General treatment of fever during pregnancy)

- (१) मधूक, चन्दन, उशीर, सारिवा, मधुयष्टी तथा पत्रक का शर्करा एवं मधु युक्त क्वाथ गर्भिणी-ञ्चर शान्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए^१।
- (२) चन्दन, सारिवा, लोष तथा मृद्वीका के क्वाथ को शर्करा मिलाकर गर्भिणी-ञ्चर शान्ति के लिए देना चाहिए^२।
- (३) पत्रक, सारिवा, पाता, तोय, तोयद तथा नागर के साथ सिद्ध किया हुआ शीतल जल गर्भिणी-ञ्चर-निवारण के लिए पीना चाहिए^३।
- (४) मधुयष्टी, चन्दन, उशीर, सारिवा एवं पत्रक के क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिलाकर पीने से गर्भिणी-ञ्चर की शान्ति होती है^४।
- (५) अतिशयतातं वर्णित ह्रीन्नेसिद क्वाथ-ञ्चर में पी लाभदायक होता है।

i) Decoction of *madhūkā*, *candana*, *uśīra*, *sārivā*, *madhuyasṭī* and *padmaka* mixed with honey and sugar is beneficial.

ii) Decoction of *candana*, *sārivā*, *lodhra* and *mīdhvīkā* mixed with sugar should be prescribed.

iii) Water medicated with *pratyasā*, *sārivā*, *pāṭha*, *toya*, *toyada* and *nāgara* and cooled should be given for drinking.

iv) Use of decoction prepared with *madhuyasṭī*, *candana*, *uśīra*, *sārivā* and *padmapatraka* mixed with sugar and honey relieves fever of pregnant woman.

v) *Hriberadi* decoction prescribed for diarrhoea is also beneficial.

दोषानुसार-ञ्चर की चिकित्सा (Treatment of fever according to predominance of doṣas)

(१) वातञ्चर चिकित्सा (Treatment of fever caused by vāta)—

निम्नाङ्कित औषधियाँ रोग की विशिष्ट अवस्था का विचार कर देनी चाहिये।

Giving due consideration to condition of disease following drugs should be used.

१. मधूकचन्दनोशीरसारिवापिपत्रकैः। शर्करामधुयुक्तः कषायो गर्भिणी-ञ्चरे॥ (योग २० स्त्री० ते० चि०)
२. चन्दनं सारिवाल्लोषमृद्वीकाशर्करानिचनम्। क्वाथं कृत्वा प्रदद्याच्च गर्भिणी-ञ्चरशान्तये॥
- पत्रकसारिवापातालोषयदनारैः। मृतं शीतं पिबेद्वारि गर्भिणी-ञ्चरवारणम्॥ (योग २० स्त्री० ते० चि०)
३. मधूक चन्दनोशीरसारिवा पत्रकैः। शर्करामधुयुक्तैः कषायो गर्भिणी-ञ्चरे॥
- चन्दनं सारिवा शर्करानिचनम्। शान्तये। (योग २० स्त्री० चि० ६६, योग २० सद्गुह्य ही)

(अ) क्वाथ (Decoction)

(१) विदारिगंधा, कलशी, गन्धर्वहस्तक, मधुयष्टी तथा भद्रदार का क्वाथ शर्करा के साथ मिलाकर तथा मातुलुङ्ग रस डालकर पान^१।

(२) विदारिगन्धादि वर्ण की औषधियों का भद्रदार मिला हुआ ईर्ष उष्ण क्वाथ पान^२।

(३) एण्ड, वरुण, दोनों बृहती तथा मधुक का क्वाथ रास्त्रा कल्क के साथ मिलाकर प्रयोग^३।

(४) दोनों पञ्चमूल (दशमूल) का शीतल या ईर्ष उष्ण क्वाथ रास्त्रा कल्क के साथ मिलाकर प्रयोग^४।

i) The decoction of *vidāṅgandhā*, *kalāśī*, *gandharvhaṣṭaka*, *madhuyasṭī* and *bhadravāra* mixed with sugar and juice of *mūlūṅga* (a variety of lemon).

ii) Lukewarm decoction of drugs of *vidāṅgandhādi* group along with *bhadravāra*.

iii) The decoction of *eraṇḍa*, *varuṇa*, both *bṛhātī* and *madhūka* mixed with paste of *rāśmā*.

iv) Either cool or lukewarm decoction of both *pañcamūla* (*dasamūla*) mixed with paste of *rāśmā*.

(आ) अभ्यङ्गार्थ तैल (Oil for massage)

कुष्ठ, मधुयष्टी, रास्त्रा, मिश्रकदम्ब, शताह्व, पत्रक, सारिवा, उशीर, उत्पल, मुस्ता, शृगालविना, करिविन्दी, वचा, पत्रक्या (क्षीरविन्दरी), हंसपादी तथा पुत्राण सभी एक-एक कर्ष लेकर दधिमण्ड (दही के पानी) के साथ पीसे। फिर इन सभी का क्वाथ बना ले। दशमूल २ पल, बला एवं अतिवला आधा-आधा पल, कोरपड, मधुयष्टि, मदयती ये तीनों तथा यव, कोल एवं कुलथ एक-एक प्रस्थ लेकर इन सभी को एक द्रोण जल में क्वथित करके एक आढ़क शेष बचावे। अब इसमें उपर्युक्त (कुष्ठदि का) क्वाथ डाल दे। इसमें दुग्ध, गोमूत्र, वारुणी तथा उत्तम दीध प्रत्येक एक-एक कुडव तथा तिल तैल डालकर वैद्य पकाए। सिद्ध हो जाने पर अग्नि से उतार ले। इस उष्ण तैल के द्वारा सम्पूर्ण शरीर की मालिश करने से तीन दिन में ही वातञ्चर नष्ट हो जाता है। गर्भ के स्थिर हो जाने पर (चतुर्थ मास लग जाने के बाद) इसका यथावत् प्रयोग प्रशस्त माना गया है^१।

१. इषानि दद्यात् साञ्जन्त्य योगवस्थाविशेषात्। विदारिगन्धां कलशीं तथा गन्धर्वहस्तकम् ॥ २१॥

मधुकं भद्रदारं च क्वाथः शर्करया युतः। वातञ्चरहरो देयो मातुलुङ्गसायुतः ॥ ३०॥ (का० सं० चि० १०)

२. वर्णो विदारिगन्धादिः क्वथितो नालिशोतलः। भद्रदारसमायुक्तो वातञ्चरहरो मतः ॥ ३१॥

एण्डो वरुणश्चैव बृहती मधुकं तथा। वातञ्चरहः क्वाथो रास्त्राकल्कसमायुतः ॥ ३२॥

द्विपञ्चमूलनिष्कवाथः कोष्णो वा यदि वा हिमः ॥ रास्त्राकल्कसमायुक्तो वातञ्चरहितो मतः ॥ ३३॥ (का० सं० चि० १०)

३. कुष्ठं मधुयष्टिं रास्त्रा मिश्रकदम्बकः ॥ ३४॥

शताह्वं पत्रकं चैव सारिवाशोमुत्पलम्। मुस्ता शृगालविना च करिविन्दी तथा वचा ॥ ३५॥

पत्रक्या हंसपादी च तथा पुत्राणश्चैव च। कर्षप्रमाणाभ्यां दधिपण्डेन पेययेत् ॥ ३६॥

ततः (सम२) रस्त्रमेधमङ्गानां निष्काथं क्वाथोद्भिदम्। भागाश्च दशमूलस्य कार्यं द्विपलसिमातः ॥ ३७॥

क्वाथितव्योऽथैव क्वथार्थपलं भिषक्। कोरपडमधुयष्टिपुण्ड्रं मदयती च ते इतः ॥ ३८॥

यवकोलकुलथानां भागाः स्युः प्रस्थसिमातः। निष्काथयैतानां द्रोणे शेषमाढकसिमातम् ॥ ३९॥

तत्र दद्यात् प्रतीकायं यत् पूर्वमुपकल्पितम्। क्षीरं तथैव गोमूत्रं वारुणीं दीधं चोत्तमम् ॥ ४०॥

भिषक्कुडवामाग्राणि तिलतैलेन योजयेत्। अवहत्याग्निना सिद्धमीधस्तोदायितं यदि ॥ ४१॥

उष्णोत्तमं तैलेन सर्वाग्राणि प्रक्षेपेत्। वातञ्चरं निहत्येतन्मक्षणीरसिभिरेव तु ॥ ४२॥

एषोऽभ्यङ्गः स्थिरे गर्भे यथावत् संशस्यते ॥ (का० सं० चि० १०)

One karṣa each of kuṣṭha, madhuvasiṭ, rāśnā, gīrikadambā, śālāhva, padmaka, sāriva, uṣṭra, utpala, manvā, śūgālavinaṁ, karaviṇḍā, vacā, payasyā, hamsapālā and pūmāṅga should be triturated with curd-water and decocted. Daśamīla two pala, balā and aṭibala each 1/2 pala, korandā, madhuśiṅga, madalyanī, yava, kola and kulathā each one prastha should be boiled with one dhruva of water till only one ādhiaka remains. Now in this decoction the earlier prepared decoction should be mixed, besides, milk, cow's urine, fine wine and good quality curd each one kuṭava and oil of tila should also be mixed and cooked. The massage with thus prepared hot oil relieves vāyā fever. This massage is advised only after fourth month of pregnancy.

(इ) पथ्य (Beneficial diet)

ज्वर के जीर्ण हो जाने पर भोजन के लिए पतली, लवण रहित पेय देनी चाहिए या वातनाशक औषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध, क्षीरान्न आश्वला मंत्रसप्त देना चाहिए।

Once the fever becomes chronic, she should be given either salt-free liquid *peya* (drinkable substance) or else milk, milk-gruel or meal-soup of wild animals medicated with drugs capable of suppressing the *vāta*.

(२) पित्तज्वर विक्रान्त (Treatment of fever caused by pitta)

(अ) आभ्यन्तर प्रयोग (Recipes for internal use)

- (१) पित्त ज्वर में सारिवादि (वर्ग की औषधियों) के कषाय में शर्करा एवं मधु मिलाकर प्रातःकाल मिलाना चाहिए।
- (२) पयस्या, क्षीरकाकोली, मुद्गीका तथा मधुक या शर्करा तथा मधु मिला हुआ पानक वैशिक ज्वर में देना चाहिए।
- (३) नीलोत्तल, पयस्या, सारिवा, मधुशर्ष, मधु, पिप्पली, मरिच, उशीर, लोघ, लाजा तथा शर्करा को दूध में मिलाकर मधुनी से अच्छी तरह मथ कर वैशिक ज्वर से पीड़ित गर्भिणी को देने से ज्वर शीघ्र शान्त हो जाता है।
- (४) मुद्गीका, पयस्क, उशीर, श्रीपणी, चन्दन (रक्त), मधुशर्ष, पयस्या (क्षीरकाकोली), सारिवा तथा आमलक का कषाय गर्भिणी स्त्री के पित्तज्वर के लिए प्रशस्त है।

i) The decoction of *sārivādī* group of drugs mixed with honey and sugar should be given in morning hours.

१. जीर्णो न भोजने पेया तन्वी लवणवर्जिता ॥ ३४॥
क्षीरं क्षीरवाज्ज्वारं रसो वा जाङ्गलो हितः ॥ ४३॥
जीर्णज्वरे सदा नार्वा वातशैरोषधीः शृतः ॥ ४४॥ (का० सं० छि० १०)
२. अथ पित्तज्वरे चापि कषायं सारिवादिकम् ॥ ४४॥
शर्करामधुसंयुक्तं पाययेत् कल्मसुस्थितम् । पयस्या क्षीरकाकोली मुद्गीका मधुकाणि च ॥ ४५॥
शर्करामधुसंयुक्तं पानकं वैशिके ज्वरे । नीलोत्तलं पयस्या च सारिवा मधुकं मधु ॥ ४६॥
पिप्पली मरिचशरीरं लोघं लाजा सरर्करा । एतत् क्षीरसमयुक्तं खञ्जने मथितं पिबेत् ॥ ४७॥
गर्भिणी ज्वरिता क्षिप्रं पित्तज्वरे प्रशाम्यति ॥ (का० सं० छि० १०)
३. मुद्गीकापयकोशीरश्रीपणीचन्दनं तथा । मधुकं च पयसा (पयस्या-शु० पा०) च सारिवामलकं तथा॥
पित्तज्वरहरः कषायो गर्भिणीनां प्रशस्यते ॥ (यो० १० स्त्री० लेग चि०)

ii) A beverage prepared with *payasyā*, *kṣīrākākolī*, *mudhūkā*, and *madhuka*, mixed with sugar and honey is beneficial.

iii) *Nlōpala*, *payasyā*, *sāriva*, *madhuvasiṭ*, *pippalī*, *marica*, *uṣṭra*, *lodhra*, *lājā* (parched paddy), honey and sugar should be pestled, mixed with milk and churned well. Use of this relieves immediately the fever caused by *pitta*.

iv) The decoction of *mudhūkā*, *padmaka*, *uṣṭra*, *śrīparā*, *candana*, *madhuvasiṭ*, *payasyā*, *sāriva* and *āmalakī* is beneficial.

(आ) बाह्य प्रयोग (External application)

(१) प्रदेह:- नल, वज्रुल तथा गुन्ना के मूल, सहा, सहदेवा, मार्कव, पाटलि, क्षीरवृक्षों तथा आम्र एवं जामुन के नवीन पत्रव, उत्पल, सारिवा, उशीर, चन्दन तथा पत्रपत्रक को बारीक पीस कर एवं घृत मिलाकर बनाया हुआ प्रदेह शीतल होता है। यह गर्भिणी स्त्रियों के पित्तज्वर का हरण करता है, तथा तर्पण होता है।

i) A poultice prepared with fine paste of roots of *nala*, *vaṅṇula* and *gundrā*, *sahā*, *sahādēva*, *mārkava*, *pāṭali*, tender leaves of *kṣīr* plants (latex yielding plants) *mango* and *blackberry*, *utpala*, *sāriva*, *uṣṭra*, *candana* and *padmapatraka* mixed with *ghṛta* is cooling. Uction of this cures *pittaja jwara* and is satisfying.

(इ) अम्यङ्गार तैल (Oil for massage)

पिसा हुआ घब एक कुडव, मखिया आषा पल, अमल (कांजी) १०० प्रस्थ, तिलतैल १ प्रस्थ लेकर तैल-पाक-विधि से तैल सिद्ध करे, यह तैल दाह एवं ज्वर हर है, तथा ज्वर नाश के लिए प्रशस्त माना गया है।

With powdered barley one *kuṭava*, *mañjiṣṭhā* half *pala* and *kāñjī* (fermented beverage) hundred *prastha*, the oil of *tila* one *prastha* should be cooked. Massage of this oil is beneficial in burning sensation and fever.

(ई) पथ्य (beneficial diet)

वैशिक ज्वर में क्षीर तथा शीतल पेय पथ्य होती है। पित्त ज्वर के जीर्ण हो जाने पर पित्तनाशक औषधियों से पकाया हुआ चणक का यूस पथ्य होता है।

In *pittaja jwara* cold drinkables and milk is beneficial. Once the fever becomes chronic, the soup of gram prepared with drugs capable of suppressing the *pitta* should be given.

१. नलवज्रुलमूलानि गुन्नामूलानि चारेत् ॥ ४८॥
सहो च सहदेवां च मार्कवं पाटलिं तथा । क्षीरिणां च प्रजालानि तथा जम्बामयोपि ॥ ४९॥
उत्पलं सारिवाशीरं चन्दनं पत्रपत्रकम् । शलध्यान्तेलाणि पिष्टानि प्रदेहः शीतलो भवेत् ॥ ५०॥
पित्तज्वरहरो नार्वास्तपणो घृतसंयुतः ॥ (का० सं० छि० १०)
२. यवपिष्टस्य कुडवो मखिषाधपलं तथा ॥ ५१॥
अम्यप्रस्थाने तैलं तैलप्रस्थं विपाययेत् । दाहज्वरहरं तैलं प्रशस्तं ज्वरनाशकम् ॥ ५२॥ (का० सं० छि० १०)
३. पित्तज्वरे हिमा पेया पथ्या क्षीरमथापि च ॥ ५८॥
जीर्णे पित्तहरेः पक्वो यूसस्तु चणकैस्तथा ॥ ५९॥ (का० सं० छि० १०)

(३) श्लेष्मज्वर-विकृतिता (Treatment of fever caused by śleśmā)

(अ) आयुर्वेद प्रयोग (Recipes for oral use)

(१) श्लेष्म ज्वर में स्त्री को रातना का क्वाथ शीतल कर मधु मिलाकर पीना चाहिए^१।

(२) रातना एवं मधु मिश्रित भद्रदार का क्वाथ अथवा पिपली एवं मधु युक्त चन्दन का क्वाथ अथवा रातना, बारा एवं अमृता का क्वाथ पीना श्लेष्म ज्वर हर है^१।

i) Cooled decoction of rāsnā mixed with honey should be given.

ii) Decoction of either bhadrādarā mixed with rāsnā and honey or candāna mixed with pipplī and honey or rāsnā. vāsā and amrā should be prescribed.

(आ) पथ्य (Beneficial)

श्लेष्म ज्वर में (गर्भिणी) स्त्री को सुखोष्ण पेय, मुद्गायूष तथा मूलीका का रस प्रशस्त है। इस व्याधि में विशेषकर ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो शरीर के लिए सात्व्य हों^३।

Lukewarm drinkables, soup of mudga (a kind of kidney bean i. e. green gram) and juice of mūlikā (radish) is beneficial, specially congenial eatables should be used.

(४) संसृष्ट ज्वर-विकृतिता (Treatment of mixed fevers)

(अ) विकृतिता सिद्धान्त (Principles of treatment)

संसृष्ट ज्वर में विद्वान वैद्य दोषों के बलबल के अनुसार औषधि-प्रयोग तथा सांनिपातिक ज्वर में विरोधशामक विकृतिता करें^३।

The wise physician should treat mixed fevers considering the relative predominance of specific dosā. In sānnpātika jwara (fever caused by vitiation of all the three dosas) the treatment to suppress all the three dosas should be given.

(आ) श्लेष्मयैविक ज्वर विकृतिता (Treatment of fever due to śleśmā with pitta)

कफयैविक ज्वर में श्रौर्णिका, अमृता तथा मधुयष्टी के क्वाथ में मधु मिलाकर देना चाहिए^४।

The decoction of śrāpārikā, amrā and madhyasṭī mixed with honey should be given.

(इ) श्लेष्मवातिक ज्वर विकृतिता (Treatment of fever caused by śleśmā with vāta)

कफवातिक ज्वर में बृहत्पञ्चमूल के क्वाथ में रातना-कल्क मिलाकर प्रातःकाल पीने को देना चाहिए^५।

१. अथ श्लेष्मज्वरे नारी रातनाक्राशं सुशीतलम् । क्षीरेण सह संयुक्तं पाययेदिति करणम् ॥ ५३॥

भद्रदारकानिकायो रातनाक्षौद्रसमायुतः । अथवा चन्दनक्राशः पिपलीक्षौद्रसंयुतः ॥ ५४॥

श्लेष्मज्वरः पेयो रातनावासोऽमृतायुतः ॥ (का० सं० खि० १०)

२. श्लेष्मज्वरे सुखोष्ण तु पेया नार्वाः प्रशस्यते ॥ ५९॥

तथैव मुद्गायूषेऽथ मौलिको रस एव च ॥ सुलास्यक्षैति कर्तव्यो व्याधावस्मिन् विशेषतः ॥ ६०॥ (का० सं० खि० १०)

३. संसृष्टे तु पिषक् प्राज्ञो योजयेत् यथावत् ॥ सन्निपातसमुत्थाने विरोधशमनं हितम् ॥ ६१॥ (का० सं० खि० १०)

४. श्रौर्णिकायुतानां तु निक्राशो मधुशीतलः ॥ ५५॥

पेयः संयष्टिमधुको ज्वरे श्लैष्मिकयैविके ॥ ५६॥ (का० सं० खि० १०)

५. महतः पञ्चमूलस्य क्वाथः श्लैष्मिकवातिके ॥ ५६॥

रातनाकल्कसमायुक्तः पेयः कल्पायति स्थितिः ॥ ५७॥ (का० सं० खि० १०)

गर्भिणी-व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा

Paste of rāsnā mixed with decoction of bhāṅgāpāncāmāla should be given in the morning.

(ई) वातयैविक ज्वर विकृतिता (Treatment of fever caused by vāta with pitta)

वातपित्तज्वर में विदारिगन्धादि गण की औषधियों के क्वाथ में शर्करा तथा मधु मिलाकर पीने को देना चाहिए, ऐसा महर्षि काश्यप का मत है^१।

Decoction of vidāriṅgandhādī group of drugs mixed with sugar and honey should be given.

(५) मद्यपा स्त्री की ज्वर विकृतिता (Treatment of fever of a wine addict woman)

मद्य सेवन करने वाली स्त्री के वातिक, पैतृक अथवा श्लैष्मिक ज्वर की चिकित्सा के लिए मद्य में आधा पानी मिलाकर देना चाहिए, एवं विभिन्न कल्पो (औषधि संयोग) को सुगं धारा सुगन्धित करके देना चाहिए ।

उस स्त्री को हरेणु, मुद्गा, चुच्चू (विशिष्ट शाक), कर्कटिका के स्वरस (यूष) तथा किञ्चित् अम्ल (मांस) रस के साथ लवण एवं स्नेह से रहित मृदु, सुरभि एवं लघु अन्न का भोजन करायें । इस आहार के द्वारा व्याधि नष्ट हो जाने पर तब मद्य की शक्ति हो जाने पर यथोक्त (वातजादि के लिए वर्णित) पथ्य का प्रयोग करें, ऐसा काश्यप का मत है^३।

To the woman addict to wine and suffering from vātika, paittika or ślāśmika fevers, wine mixed with equal quantity of water should be given, besides all the medicinal preparations should also be given after being incensed with wine.

She should be given soft and sweet smelling diet of light cereals mixed with salt and fat free soup of hareṇu, mudga (green gram), cucu and karṇatikā (cucumber) alongwith slightly sour meat soup. Once the disease is cured by this diet and the effect of wine has passed off, she should be given beneficial diet on the basis of specific dosā.

(६) विषम ज्वर विकृतिता (Treatment of viṣama i.e. intermittent fever)

शुण्ठी को अन्न क्षीर में पीस कर पीने से विषम ज्वर नष्ट होता है^३।

Use of śuṇṭhī triturated with goat milk relieves viṣama fever.

(७) ज्वर के उपद्रवों की चिकित्सा (Treatment of complications of fever)

(अ) शिरोगेय विकृतिता (Treatment of disorders of head)

गर्भिणी के ज्वर में शिरोगेय हो जाने पर यथावत् चिकित्सा करनी चाहिए । ज्वर का वेग पूर्णरूपेण शांत हो जाने पर भी गुरु भोजन नहीं देना चाहिए^४।

१. क्वाथो विदारिगन्धादेः शर्करामधुयोजितः ॥ ५३॥

वातपित्तज्वरे पेय इति ह स्माह काश्यपः ॥ ५८॥ (का० सं० खि० १०)

२. अथ या मद्यपा नारी शृणु तत्प्राशिक्षितस्तम् । वातिके पैतृके वाडिपे श्लैष्मिके च विद्यान्ते ॥ ६२॥

ज्वरे दद्यात् सुगं नार्वा जेलनार्धेन योजिताम् । सुरया वासयित्वान्नं ततः कल्पं प्रदायेत् ॥ ६३॥

हरेणुमुद्गाचुच्चूनां कर्कटकाश्च रसेन तु । रसेन किञ्चित्स्नेन तत्पूरयन्वाग्निं भोजयेत् ॥ ६४॥

लवणक्षेत्रहीनानि मृदूनि सुरभीणि च । आहारेण गदे भग्रे मद्यस्तेरामे कृते ॥ ६५॥

यथोक्ता तु क्रिया यथा यथास्मिति करणम् ॥ ६६॥ (का० सं० खि० १०)

३. पीत विश्रामजालीरनशयेद्विषमज्वरम् ॥ (यो १० लीरो ० चि० एवं भा० ३० चि० ७०/६६)

४. शिरोगेये तु कर्तव्यो यथावत्पेषजक्रमः । पणवेगे ज्वरे कृत्वे गुरु नैव प्रशस्यते ॥ १७॥ (का० सं० खि० १०)

If a febrile pregnant woman suffers from disorders of head, then appropriate treatment for these should be prescribed. Heavy diet is contraindicated even after normalization of fever.

(आ) तुष्णा चिकित्सा (Treatment of thirst)

ज्वर में तुष्णा लगने पर सुखोष्ण जल पीना चाहिए। जल एवं अन्य ज्वर में शीतल जल विष तुल्य होता है। शैतिक ज्वर में भी श्रुशीत (गरम करके ठंडा किया हुआ) जल ही प्रयोज्य है। ताम्र अदि धातु या पत्थर के बर्तन में पका कर शीतल किया हुआ जल प्यास को बुझाता है। उपर्युक्त विधि विशेषकर तरुण ज्वर के लिए है। ज्वर का वेग समाप्त हो जाने पर प्रत्येक ज्वर में (दोष प्राधान्य के अनुसार) तुष्णा शाम्भ औषधियों से पकया हुआ शीतल अथवा अन्य (उष्ण या सुखोष्ण) जल देना चाहिए।

To quench the thirst, she should take luke warm water. In *vāta* and *ślesmika* fever cold water is very harmful like a poison, even in *pitta* fever boiled and cooled water should be given. The water boiled in pot made of copper etc. metal or stone and cooled relieves the thirst. Above method is beneficial in fevers of recent origine. In all types of fever after their remission, the water boiled with drugs capable of suppressing thirst then cooled or luke warm should be given.

गर्भिणी के उदावर्त की चिकित्सा (Treatment of udāvarta during pregnancy)

यदि गर्भिणी को आठवें मास में उदावर्त के कारण विषय हो जाये एवं अनुवासन बसित देने पर ठीक न हो तो उसे अनुवासन से असाध्य समझ कर विकार का शमन करने वाली औषधियों (निम्नाङ्कित) से कल्पना करके निरह बसित का प्रयोग करें।

वीरण, शालि, षष्टिक, कुश, काश, इक्षुवातिका, वैतस एवं परिव्याध के मूल; भूतीक, अनन्ता, काशमी, पल्लक, मधुक, मुद्गीका (के कलक) को क्वाथ विधि से आधा जल एवं आधा दूध डालकर पकावे, जब अष्टमांश शेष बचे तो उसी रस (क्वाथ) में प्रियाल, विभीकमज्जा, तिलकल्क एवं थोड़ा सा तवण मिलाकर ईष्ट उष्ण द्रव्य से निरह बसित दे^१।

महर्षि वाग्भट ने उदावर्त-विषय में वातहर एवं स्निग्ध अन्नपान^२ में उपचार तथा मधुक से सिद्ध तैल से अनुवासन का विधान बताया है एवं उससे ठीक न होने पर निरह बसित^३ के प्रयोग का निर्देश किया है। बसित-विधान के द्रव्यों में चक्रकोट वर्णन का ही अनुसरण किया है, क्वाथ के द्रव्यों में षष्टिक का उल्लेख नहीं किया।

१. उत्तरभागं तु तुष्णायां नायुषां प्रतिवेज्जलम् । वातश्लेष्मसमुद्ये तु ज्वरं नीरं विधायेत् ॥ १४॥

अथ पित्तकृते चापि श्रुतशीतं प्रशस्यते । कुप्याषाणानिष्पक्वं शीतं तुष्णातिवर्धनम् ॥ १५॥

ज्वरे तु तल्ले दृष्टे विधेरेष विशेषतः । भगवतो तु कर्तव्यं तुष्णाग्रशमनैः श्रुतम् ॥ १६॥

ज्वरं ज्वरं समसाद्य शीतं वा यदि वेतम्(ते) ॥ १७॥ (का० सं० नि० १०)

२. यस्याः पुनरुदावर्तविषयः स्यादष्टमे मासे न चानुवासनसाध्यं मन्वेत ततस्तस्याष्टादिकाप्रशमनमुपकल्पयेत्किञ्चन ।

तत्र वीरणशालिषष्टिककुशकाशेक्षुवातिकावेतसपरिव्याधमूलानां भूतीकानन्ताकाशमपल्लकमधुकमुद्गीकानां च पयसाऽधोदके नोद्विष्य सः प्रियालविभीकमज्जतिलकल्कसंयुक्तमीषव्रणमनतुण्यं च निरहं दद्यात् ॥ (च० सं० शा० ८/२९)

३. उदावर्तं तु गर्भिण्याः सेहैराश्रुतं जयेत् ॥ २१॥ योग्यैश्च बसिभिः ॥ (अ० ह० शा० २)

४. यस्याः पुनरुदावर्तविषयः स्यातां वातहरस्निग्धपौर्णचरेत् । अष्टमे तु मासे मधुकसिद्धेन तैलेनानुवासयेत् ।

तदाभिमर्दौ वीरणशालिषष्टिककुशकाशेक्षुवातिकावेतसपरिव्याधमूलानां भूतीकानन्ताकाशमपल्लकमधुकमुद्गीकानां च पयसाऽधोदकेनोद्विष्य रसं तेन प्रियालविभीकमज्जतिलकल्कसंयुक्तेनेषव्रणोपेन निरहयेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/२५)

If constipation occurring due to *udāvarta* during eighth month of pregnancy is not relieved either by use of *anuvasāna basti* (uncting enema) or else with unctuous edibles mixed with substances capable of suppressing *vāta* alongwith uncting enema with the oil prepared with *madhuka*, then it should be considered as incurable by this procedure and *nirūha basti* (evacuative enema) prepared with following drugs should be used.

Roots of *vīraṇa*, *śālī*, *ṣaṣṭika*, *kūśa*, *kāśa*, *ikṣuavālika*, *vetasa* and *pariplyādhā*; *bhūṭika*, *ananta*, *kāśmārī*, *pariṣṭaka*, *madhuka* and *mṛdāwikā* all should be cooked with standard procedure of decoction keeping half quantity of water and half milk, when quantity of water and milk together is reduced to oneeighth, it should be filtered. Now in this filtrate paste of *pryāṭla*, kernel of *bibhātika* and *tila* along with little quantity of salt should be mixed and *nirūha basti* of this very substance keeping it luke warm should be given. *Vāḍbhata* has omitted *ṣaṣṭika*.

निरह बसित के पश्चात्कर्म (Management after use of evacuative enema)

व्यापत विषयों चैतां सुखसलिलपरिषिकाङ्गी स्वीर्धकर्मविदाहिनामाहारं भुक्तवतीं सायं मधुरकसिद्धेन तैलेनानुवासयेत् ॥ (च० सं० शा० ८/२९)

विगतविषयों च स्नातोशितां सायं तैवैव तैलेनानुवासयेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/२५)

विषय के दूर हो जाने पर, सुखोष्ण जल से स्नान की हुई, स्थिरताकारक (गर्भ को स्थिरताकारक) एवं अविदाही आहार का भोजन की हुई स्त्री को सायं मधुरक (मधुर वर्ग की औषधियों) से सिद्ध तैल से अनुवासन बसित दे^१।

महर्षि वाग्भट ने संक्षेप में लिखा है, कि विषय ठीक हो जाने पर स्नान एवं भोजन देकर सायं उसी तैल (मधुक सिद्ध तैल) से अनुवासन बसित दे^१।

Once the constipation is relieved by use of above enema, she should be given bath with luke warm water and such dietetics which do not produce burning sensation and are beneficial to the fetus. In the evening uncting enema with oil medicated with the drugs of *madhura* group or *madhuka* should be given.

बसित दान काल में गर्भिणी की स्थिति (Posture of woman during enema)

न्युब्जां स्तेनामास्थानानुवासनाध्यापुचरेत् ॥ (च० सं० शा० ८/२९)

गर्भिणी को आस्थापन एवं अनुवासन बसित न्युब्ज स्थिति में देना चाहिए।

To a pregnant woman cleansing and uncting enema should be given keeping her in humpbacked or flexed posture.

विमर्श (Comments)

न्युब्ज स्थिति में सम्भवतः गर्भ का शिर या नीचे स्थित अंग ऊपर की ओर चले जाने से बसित प्रवेश में सुविधा होगी। गर्भिणीपरिचर्याकर्ता वर्णित अष्टम मास की परिचर्या में महर्षि वाग्भट ने इसी स्थिति में बसित देने का विधान बताया है।

Probably in this posture presenting part of fetus might be getting pushed upwards thus

facilitates entry of enema material. In normal antenatal care also similar posture for enema during eighth month of pregnancy is advised.

उदावर्त की उपशेरा का परिणाम (Effect of neglect in the treatment of udavarta)

उदावर्तों द्वारा पोषितः सहसा सर्गर्भा गर्भिणी गर्भमथवातिपातयेत् ॥ (च० सं० शा० ८/२९)

उदावर्तों हि समुपेक्षितः सहसा सर्गर्भा गर्भिणीमतिपातयेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/२६)

..... हन्यास्तगर्भा स हि गर्भिणीम् ॥ (अ० ह० शा० २/२२)

उदावर्त की चिकित्सा में उपेक्षा करने पर वह सहसा गर्भ के साथ ही गर्भिणी को नष्ट कर देता है, अथवा केवल गर्भ का ही पाल देता है।

महर्षि व्यास ने भी लिखा है कि समुपेक्षित उदावर्त गर्भ युक्त गर्भिणी को मार डालता है।
Udavarata if neglected or not treated properly, kills both i.e. mother and fetus or else initiates expulsion of fetus.

गर्भिणी अतिसार (Garbhini-dīsāra or diarrhoea during pregnancy)

अतिसारो तु गर्भिण्याः समुत्पद्ये भिषजितम् ॥ ६६॥

वातिके वैतिके चैव श्लैष्मिके च प्रवक्ष्यते ॥ ६७॥ (का० सं० खि० १०)

गर्भिणी स्त्री को अतिसार उत्पन्न हो जाने पर वातिक, वैतिक एवं श्लैष्मिक (प्राधान्य) के आधार पर चिकित्सा करेंगे।
Now the treatment of diarrhoea of a pregnant woman would be described on the basis of dominance of *dosā* i.e. *vātika*, *paitika* and *ślāishmika* etc.

निदान (Etiology)

विरुद्धाध्यशनाजीर्णस्तथैवात्यशनादपि ॥ ६७॥

भयोद्वेगविघाताद्वा (भयोद्वेगविघाताद्वा-शु० पा०) सङ्घातात् पूरणात् क्षयात् ।

कन्दमूलफलैरामैर्दुष्टतैर्यनिषेवणात् ॥ ६८॥

तौष्ट्यादुभुक्षया छो(शो)कदादुर्लीभ्यादियोजनात् ।

अव्यातोश्च स(मु)द्रेकादतीसारः प्रवर्तते ॥ ६९॥ (का० सं० खि० १०)

विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण तथा अत्यधिक भोजन, भय, वेगों के विघात, संघात (टोस या कठिन आहार द्रव्यों का सेवन), पूरण (अतिसंतर्पण), क्षय, कच्चे कन्द, मूल, फल तथा दूषित जल के प्रयोग, रुखा, चुपचा, शोक तथा गुरु एवं अतिथण्डि भोजन करने से उत्पन्न अव्यातु (शीत स्थित जलीय धातु) के उद्रेक (अवेग से निष्कासन) के कारण अतिसार होता है।

Due to use of incompatible edibles, eating before previous meal is digested, indigestion, over-eating, fear, suppression of natural urges, consumption of hard or solid substances, satiation, emaciation, use of uncooked roots, rhizomes or fruits and polluted water, dryness, hunger, grief, eating of heavy or *abhisyandi* (likely to cause obstruction to *strotasas*) articles, the water content of body is excreted with force, which results in diarrhoea.

गर्भिणी-व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा

२६९

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सभी कारणों को सामान्य रूप से पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है (१) भोजन वैषम्यः- जिसके कारण पाचन संस्थान में पाचन साम्य-व्यी विकृति हो अतिसारोत्पत्ति (इण्डिजेस्टन-डाइअर्रिया) (२) कच्चे फल या दूषित जल सेवन-जन्मः-अर्थात् जीवाणु प्रवेश के कारण या जीवाणु जन्म (इन्फेक्टिव डाइअर्रिया) (३) शोक भयादि जन्म या मानसिक आकस्मिक आपात के कारण (नॉर्वेस डाइअर्रिया) (४) शारीरिक धातुओं के वैषम्य यथा क्षय, पूरण आदि से (न्यूट्रिशनल डाइअर्रिया) (५) दोषजन्म या शारीरिक विकृतियों की निकालने के लिए (टोक्सिक डाइअर्रिया)। ये सभी कारण किसी भी अवस्था में अतिसारजनक हो सकते हैं, परन्तु गर्भिणी में अल्प विकार भी अतिसारोत्पादक हो सकते हैं।

All the above mentioned etiological factors can be grouped under five categories : (1) Dietetic abnormalities producing digestive disturbances resulting into diarrhoea or indigestion diarrhoea. (2) Use of uncooked fruits and polluted water resulting into entry of infective organisms or infective diarrhoea. (3) Fear, grief etc. psychological trauma or nervous diarrhoea. (4) Satiation or emaciation etc. or nutritional diarrhoea. (5) Due to *dosas* or other diseases of body or toxic diarrhoea. All these conditions can cause diarrhoea to any body, however, during pregnancy presence of least abnormalities may produce diarrhoea.

गर्भिणी अतिसार चिकित्सा (Treatment of diarrhoea during pregnancy)

(अ) चिकित्सा सिद्धान्त (Principles of treatment)

आमातिसारे सञ्जाते पाचनानि प्रदापयेत् ॥ ७०॥

पक्वसंग्रहणे पथः (पक्वे संग्रहणं पथं-शु० पा०) सर्वेषामिति निश्चयः ॥ ७१॥

(का० सं० खि० १०)

आमातिसार उत्पन्न हो जाने पर पाचन औषधियों (आम के पाचनार्थ) का प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के पक्वातिसार में स्तम्भक (संग्रहण) चिकित्सा लाभकारी है ऐसा आचार्यों का मत है।

In *āmatīsāra* (diarrhoea having sufficient quantity of mucus in faeces) *pācana* (digestive) drugs and in *pakvātīsāra* (faeces not containing mucus) *stambhaka* (constipating) drugs should be prescribed.

(आ) अतिसार की सामान्य चिकित्सा (General treatment)

(१) कल्याणकावलेह (Kalyāṇakāwaleha)

पिप्पली, धातकी (पुष्प), लोष, समंग (लज्जालु), पद्मकेशर, पद्म, मोचरस, दीर्घवृन्त वृक्ष की त्वक् एवं केशर (नागकेशर) का अतिमृक्ष चूर्ण कर लें। इसमें घृत, मत्स्यण्डिका तथा मधु मिलाकर अवलेह बनायें। इसे कल्याणक अवलेह कहते हैं। यह सभी प्रकार के अतिसारों का नाश करता है।

Finely powdered *pippali*, flowers of *dhātaki*, *lodhra*, *samangā*, *padmakēśara*, *padmā*, *mocarasa*, stem bark of *dṛghavarṇita* and *nāgakeśara* should be mixed with *ghṛta*, treacle and honey. This electuary is known as *kalyāṇakāwaleha* and is beneficial in all types of diarrhoea.

१. पिप्पल्यो धातकी लोषं समङ्गा पद्मकेशरम् । पद्मा मोचरसश्च दीर्घवृन्ततोस्त्वचः ॥ ८८॥

केशरं चोति चूर्णानि श्लक्ष्णान्येतानि चूर्णयेत् । घृतं मत्स्यण्डिका क्षौद्रं लेहीभूतानि लेहयेत् ॥ ८९॥

लेहः कल्याणकस्त्वेष सर्वातिसारनाशनः ॥ ९०॥ (का० सं० खि० १०)

(२) हीबेरालि क्राथ (*Hibberaldi decoction*)

होबेर (उशीर भेद), अरुतु, रक्तचन्दन, कला, धान्यक, कलसादनी, मुस्ता, उशीर, यवास, पर्पट तथा विषा को समान भाग लेकर क्वाथ बनकर गरिष्मणी स्त्री द्वारा पान अनेक वर्णों तथा पीड़ाओं से युक्त अतिसार, रक्तस्राव, ज्वर तथा सूतिकाव्यापद में लाभदायक है। मुनियों ने इस योग को उत्तम कहा है।

Use of decoction made with equal quantity of *hibbera arali, rakta candana, bala, dhanyaka, vatsadani, musta usira, yavasa, parpati* and *visa* relieves diarrhoea associated with various types of pains, bleeding and fever.

(३) अन्य योग (*Other recipes*)

शुण्ठी एवं बिल्व के कषाय में यव का ससू मिलाकर गरिष्मणी स्त्री पान करें तो वमन एवं अतिसार दोनों का ही नाश होता है।

Flour of parched barley mixed with decoction of *sunthi* and *bilva* is beneficial in vomiting and diarrhoea both.

कसक (कुटजजलक), दाडिम, पाठा, बालबिल्व (कच्चा बेल), कला तथा जापुन एवं आम के पक्ख इन्में से जितनी भी औषधियाँ मिल सकें उन्हें शर्करा एवं दधि के साथ स्त्री को अतिसार में सेवन कराना चाहिए।

Available drugs out of *vatsaka, dadima, palha, unripe young fruit of bilva, bala* and tender leaves of mango and blackberry should be mixed with sugar and curd. Use of this relieves diarrhoea.

(३) ज्वरातिसार चिकित्सा (*Treatment of diarrhoea with fever*)

समझा (मंजीठ), मधुक, लोष (चूर्ण) और फणित का शर्करा के साथ सेवन गरिष्मणी स्त्री के ज्वरातिसार, आमातिसार एवं रक्तितिसार में लाभदायक है।

Powder of *samangra (manjishta), madhuka, and lodhra* mixed with *phaniya* (inspissated juice of sugar cane or molasses) and sugar is beneficial in diarrhoea associated with fever, mucus or blood.

(३) आमातिसार चिकित्सा (*Treatment of amatisara or diarrhoea having excessive mucus in feces*)

ज्वरातिसारानर्त वर्णित योग लाभदायक है।

The prescription given for diarrhoea with fever is beneficial.

१. (अ) हीबेरालुक्कचन्दनलोषायाककलसादनी। मुस्तोशीयवासपर्पटविषाक्राथं पिबेद् गुणिणी ॥

नानावर्णज्वातिसारकारो रक्तक्षुतो वा ज्वरे। योगोऽयं मुनिभिः पुरा निमित्तः सूर्यामयेष्टतमः ॥ (यो० २० स्त्री ते० चि०)

(आ) हीबेरालु पिबेत् गरिष्मणी। नानावर्णरक्तज्वातिसारादके सूर्यामयेऽष्टतमः ॥ (पा० प्र० चि० ७०/६८, यो० २० सद्दश ही)

२. यो० २० स्त्रीते० चि० वमनीचिकित्सानर्त वर्णित।

३. कसकं दाडिमं पाठा बिल्वबिल्वबलासथा (बालबिल्व-शु० पा०) ॥ ८॥

जम्ब्यापक्खज्जैव यथा लाभेन सताम। शर्कराधिसंयुक्तं स्त्रीणाञ्चैवातिसारके ॥ ९॥ (ही० सं० तृती० ५१/८, ९)

४. ज्वरातिसारे गरिष्मण्यः शर्तं सामे सशोणिते। समझा मधुकं लोषं फणितं शर्कराचिन्तम् ॥ (यो० २० स्त्रीते० चि०)

(१) रलेष्माचित आमातिसार चिकित्सा (*Treatment of amatisara having association of shlesma*)

कुटज के बीज, मुस्ता, पाठा, अजमोद, सरल, अतिविषा तथा शुभा को पीसकर सुखोष्ण जल के साथ रलेष्माचित आमातिसार में सेवन कराना चाहिए।

Powder of seeds of *kuja, musta, palha, ajamoda, sarala, ativisa* and *subha* with lukewarm water is beneficial.

(२) पित्ताचित आमातिसार चिकित्सा (*Treatment of amatisara having association of pitta*)

पाठा, चन्दन, कुटजफल, अतिविषा तथा मुख्या को पीसकर स्वच्छ जल के साथ सेवन पित्ताचित आमातिसार में करना चाहिए ऐसा भगवान् काश्यप का मत है।

Powder of *palha, candana, seeds of kuja, ativisa* and *mukhya* with water is beneficial.

(३) वाताचित आमातिसार चिकित्सा (*Treatment of amatisara associated with vata*)

हिंगु, सैन्धव, नागकेशर, दोनों बृहती, कुटजफल, पिप्पलीमूल, मुख्या तथा अतिविषा को पीसकर सुखोष्ण जल से वातोचित आमातिसार में सेवन कराना चाहिए।

Powder of *hingru, saindhava, nagakesara, both brhaties, seeds of kuja, pipplimula, mukhya* and *ativisa* should be given with lukewarm water.

(४) सन्निपातोष्य आमातिसार चिकित्सा (*Treatment of amatisara having association of all three dosas*)

सन्निपातोष्य आमातिसार में बृहत्यादि गण की औषधियों का क्वाथ पीना चाहिए।

Decoction of *brhatyadi* group of drugs is beneficial.

(ए) रलेष्मातिसार चिकित्सा (*Treatment of diarrhoea having dominance of kapha*)

(१) रलेष्मिक अतिसार में अम्बुषादि गण की औषधियों के क्वाथ में तण्डुलोदक एवं मधु मिलाकर पीने से भिन्नवर्ष का विबन्ध होता है अर्थात् अतिसार नष्ट होता है।

(२) कौटज फल, धातकी, मरिच, लोष, कट्वं तथा देवदार को पीसकर तण्डुलोदक एवं मधु के साथ प्रयोग रलेष्मातिसार का नाश करता है।

(३) नलिन के केशर को तण्डुलोदक में पीसकर मधु मिलाकर पीने से स्त्री का रलेष्मातिसार नष्ट होता है।

१. कुटजस्य च बीजानि मुस्ता पाठा तथैव च ॥ ७०॥

अजमोदोऽथ सरलं तथा चातिविषा शुभा। अमे रलेष्माचिते पेयेमेतत् पिबे सुखान्मुना ॥ ७१॥ (का० सं० वि० १०)

२. पाठाचन्दनभागश्च कुटजस्य फलानि च। तथा चातिविषा मुख्या पिबेतेहिक्काचुना ॥ ७२॥

अमे पित्ताचिते पेयमिति ह स्माह काश्यपः ॥ ७३॥ (का० सं० वि० १०)

३. हिंगुसैवनागाश्च बृहत्को कौटजं फलम् ॥ ७३॥

तथा पिप्पलीमूलं च मुख्या चातिविषा नृप ॥ अमे वातोचिते पेयेमेतत् पिबे सुखान्मुना ॥ ७४॥ (का० सं० वि० १०)

४. बृहत्यादिरु पातव्यः सन्निपात समुचिते ॥ ७५॥ (का० सं० वि० १०)

५. रलेष्मिके मधुसंयुक्ततण्डुलोदकसंयुतः। अम्बुषादिगणः पेयो भिन्नवर्णचिकित्सनः ॥ ७६॥

अथवा कौटजं हिक्का फलं क्षौद्रेण संयुतम्। धातकी मरिचं लोषं कट्वर्कं देवदार च ॥ ७७॥

तण्डुलोदकसंयुक्तं रलेष्मातिसारनाशनम्। तण्डुलोदकपिबे वा केसरं नलिनस्य तु ॥ ७८॥

मधुयुक्तं पिबेन्नारी रलेष्मातिसारनाशनम् ॥ ७९॥ (का० सं० वि० १०)

(i) Decoction of *ambasīhādi* group of drugs mixed with ricewater and honey is beneficial.

(ii) The paste of fruits of *kuṇḍa*, *dhātaki*, *marica*, *lodhira*, *kāṇvāṅgā* and *devadāru* mixed with rice water and honey cures *ślesmāśāra*.

(iii) Use of potion prepared with *malina keśāra* (saffron of locus) triturated with ricewater and mixed with honey cures *ślesmāśāra*.

(२) **पित्ततिसार चिकित्सा** (*Treatment of diarrhoea having dominance of pitta*)

(१) कुशल चिकित्सकों का कथन है कि न्योषादि गण के द्वाय को मधु के द्वारा मीठा करके पीने से पित्ततिसार नष्ट होता है^१।

(२) कण, धातकी पुष्प, मधुक तथा (कच्चे) बिल्व के गूदे के क्वाथ को शर्करा एवं मधु मिलाकर प्रयोग पित्ततिसार नष्ट करता है^१।

(३) पद्म, समझा (लज्जालु), आम्र की गुठली, मधुक, पद्मकेशर, लोष, मोचरस तथा शर्करा एवं मधु से मिश्रित योग का प्रयोग पित्ततिसार नाशक होता है^१।

(i) Decoction of *nyagrodhādi* group of drugs sweetened with honey cures *pittāśāra*, is the opinion of wise physicians.

(ii) Use of decoction of *kanā*, flowers of *dhātaki*, *madhuka*, pulp of (unripe) fruit of *bilva*, mixed with sugar and honey is beneficial.

(iii) *Padma*, *samaṅgā* (*lajjālū*), kernel of mango fruit, *madhuka*, *padmaśāra*, *lodhira*, *mocarasa* (powder or paste of all these drugs), sugar and honey mixed together and taken cure *pittāśāra*.

(अ) **वाततिसार चिकित्सा** (*Treatment of diarrhoea having dominance of vāta*)

(१) एराड को छोड़कर बाकी खुशुक पञ्चमूल की औषधियों (सुरापणी, माषपणी, पुनर्नवा एवं बला^३) का क्वाथ काला तथा कट्वांग मिलाकर प्रयोग वाततिसार नाशक होता है।

१. न्योषादिस्तु निर्गृहः शौरेण मधुरीकृतः ॥ ७९॥

पित्ततिसाराशनः कुशलेः परिकीर्तितः। कणा धातकिपुष्पं च मधुकं बिल्वपेयिका ॥ ८०॥

शर्करामधुसंयुक्तं पित्तवृद्धिनाशनम्। पद्मं समझमाश्लिष्य मधुकं पद्मकेशरम् ॥ ८१॥

लोषं मोचरसश्चैव शर्कराश्वत्थसंयुतः। पित्ततिसाराशनो योग एष विधीयते ॥ ८२॥ (का० सं० खि० १०)

२. एराडवर्जं खुड्डकं पञ्चमूलं शृतं हितम्। कालाकट्वङ्गसंयुक्तं वातातीसारनाशनम् ॥ ८३॥

पद्मं समझमाश्लिष्य बृहती बिल्वपेयिका। श्लक्ष्णपिष्टं पिबेदना वातातीसारनाशनम् ॥ ८४॥

मुस्ताबिल्वशलाहूनि अनन्ता मधुकं तथा ॥ ८५॥

श्लक्ष्णपिष्टं पिबेदना सर्पिर्गुडसमायुतम्। वातातीसारशान्त्यर्थं यथावदिति कथयः ॥ ८७॥ (का० सं० खि० १०)

३. चरक एवं सुश्रुत ने पञ्च पञ्चमूल तथा अष्टाङ्गसंह ने सप्त पञ्चमूल का वर्णन दिया है, परन्तु किसी ने भी खुड्डक पञ्चमूल शब्द से कोई वर्णन नहीं दिया। महर्षि चरक द्वारा वर्णित मध्यम पञ्चमूल के अतिरिक्त अन्य किसी भी पञ्चमूल में एराड का उल्लेख नहीं है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि खुड्डक पञ्चमूल से यहाँ चरक वि० स्थान १/४३ वर्णित मध्यम पञ्चमूल अपेक्षित है न कि सामान्य तप्त पञ्चमूल।

(२) पद्म, समझा (लज्जालु), आम्र की गुठली, बृहती तथा (कच्चे) बिल्व के गूदे को चिकना पीसकर दही के साथ सेवन करने से वाततिसार नष्ट होता है।

(३) मुस्ता, बिल्व-शलाहू, अनन्ता तथा मधुक को चिकना पीसकर, यौ तथा गुड़ मिलाकर दही के साथ वाततिसार शान्त्यर्थ प्रयोग करना चाहिए ऐसा महर्षि काश्यप का मत है।

(i) Use of decoction of *khudlāka pāñcamūla* except *erandā* (*mudgaparāṇ*, *māsaparaṇ*, *puṇaravā* and *balā*) mixed with *katā* and *kāṇvāṅgā* cures *vātāśāra*.

(ii) Use of *padma*, *samaṅgā* (*lajjālū*), kernel of mango fruit, *bilva* and pulp of fruit of *bilva* pestled nicely with curd, cures it.

(iii) Finely pestled *musā*, unripe young fruit of *bilva*, *anantā* and *madhuka* mixed with curd, *ghṛta* and *juggery* should be used for the relief of *vātāśāra*.

(अ) **शूल युक्त वाततिसार चिकित्सा** (*Treatment of vātāśāra associated with pain*)

पिप्पली, धातकी (पुष्प), पद्म, समझा (लज्जालु), मोचरस, मत्स्यपिडका तथा इन्द्रयव इन सभी को पीसकर तण्डुलोदक मिलाकर सेवन शूल युक्त वाततिसार में हितकारी होता है^१।

Use of (powdered) *pippalī*, *dhātaki* (flowers), *padma*, *samaṅgā*, *mocarasa*, *matsyap-dīlā* (treacle) and *indrayava* with rice water relieves painful *vātāśāra*.

(अ) **रक्तातिसार चिकित्सा** (*Treatment of raktaśāra or diarrhoea associated with blood in stool*)

(१) बाणमूल क्वाथ में त्रुणी के बीज मिलाकर शर्करा एवं मधु मिश्रित प्रयोग रक्तातिसार नाशक है^१।

(२) पद्म, समझा (लज्जालु), मधुक, चन्दन तथा पद्मकेशर को (चूर्ण की) मधु मिलाकर दुग्ध से पान रक्तातिसार नाशक है^१।

(३) कृष्ण तिल, समझा (लज्जालु), मधुयष्टी तथा उत्पल (नीलकमल) को कच्चे दूध से पीने से रक्तातिसार नाश होता है^१।

(४) मोचरस, तिल, लोष, उत्पल (नीलकमल) तथा कमल को क्षीर के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नाश होता है^१।

(५) पयस्या (क्षीरकाकोली), चन्दन, लोष तथा पद्मकेशर को मधुमिश्रित कर दुग्ध के साथ पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है^१।

(i) Use of decoction of root of *bāṇa* mixed with seeds of *trapaṣṭī* (cucumber), sugar and honey cures *raktaśāra*.

१. पिप्पल्यो धातकी पद्मं समझा मोचरो रसः। मत्स्यपिडकेन्द्रधाम्यं च पिष्टमेनेनूपेतम् ॥ ८५॥
तण्डुलोदकसंयुक्तं सशूले वातिके हितम् ॥ ८६॥ (का० सं० खि० १०)

२. बाणमूलस्य निष्काशस्त्रुणीबीजसंयुतः। शर्करामधुसंयुक्तो रक्तातीसारनाशनः ॥ ९६॥

पद्मं समझा मधुकं चन्दनं पद्मकेशरम्। पयसा मधुसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥ ९७॥

तिलान् कृष्णान् समझा च यष्टीमधुकमुत्पलम्। पिबेदमेन पयसा रक्तातीसारनाशनम् ॥ ९८॥

मौचो रसस्तिला लोषयुत्पलं कमलं तथा। पिबेत् क्षीरेण संयुक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥ ९९॥

पयसा चन्दनं लोषं पद्मकेशरमेव च। पयसा मधुसंयुक्तं पिबेदरक्तातिसारिणी ॥ १००॥ (का० सं० खि० १०)

(ii) Powder of *padma*, *samāṅgā*, *madhuka*, *candana*, and *padmakeśara* mixed with honey and taken with milk cures *raktāṁsāra*.

(iii) Use of powder of black *tila*, *samāṅgā*, *madhyasī* and *upala* with unboiled milk is beneficial.

(iv) Use of *mocarasa*, *tila*, *lodhra*, *upala* (*nīlakamala*) and *kamala* with milk cures *raktāṁsāra*.

(v) Powder of *payasā*, *candana*, *lodhra* and *padmakeśara* mixed with honey and taken with milk cures *raktāṁsāra*.

प्रवाहिका विकृति (Treatment of pravāhikā or dysentery)

(१) काशमेरी के मूलत्वक् (पृष्ठत्वक्) तथा श्यामा के मूल की दधिपण्ड के साथ बनाई हुई यवगू को थोड़े से घृत के साथ सिद्ध करके पीने से प्रवाहिका पीड़ित (गर्भिणी स्त्री) सदा सुख प्राप्त करती है^{१,३}।

(२) कितातितक, लोष, मधुयष्टी, फणित तथा तिलकल्क का शर्करा एवं मधु मिलाकर तण्डुलीदक के साथ प्रयोग प्रवाहिका का नाश करता है^१।

(३) कपिष्य, विल्व, माष, मोचरा, पिप्पली तथा शृङ्गेर (आर्द्रक) प्रत्येक का पृथक्-पृथक् एक-एक कर्ष कल्क तथा दही आधा प्रस्थ इसमें गुड़ द्वारा बनाई हुई मद्य डालकर खड़ (एक विशिष्ट आहार कल्क) तैयार कर, घृत और मधु सहित (मिलाकर) भोजन के जर्ण हो जाने के बाद पान करने से जीर्ण प्रवाहिका नष्ट होती है, तथा प्रणौ एवं बल का वर्धन होता है^१।

(४) फणित, तिलकल्क, शर्करा तथा मधुक का तण्डुलीदक के साथ मिलाकर प्रयोग प्रवाहिका को शीघ्र ही नष्ट कर देता है^१।

(५) कितातितक, लोष तथा मधुयष्टी का शहद के साथ पान प्रवाहिका को शीघ्र नष्ट करता है^१।

(६) गर्भिणी को आम एवं रक्तमिश्रित प्रवाहिका में आम एवं जामुन की त्वचा के क्वाथ में लाजा का सत्व मिलाकर चाटने से लाभ होता है, यह प्रयोग ग्रहणी को भी नष्ट करता है^१।

(i) Rice gruel prepared with stem or root bark of *kāśmarī* and root of *triprīta* and *dadhī-*

१. काशमरीमूलकल्कः श्यामामूलं तथैव च ॥ ९०॥

यवागू दधिपण्डेन सिद्धमल्पघृतं मिवत् । प्रवाहिकार्ता सततं तथा सम्पद्यते सुखी ॥ ९१॥

कितातितकं लोषं यष्टीमधुकमेव च । फणितं तिलकल्कश्च शर्करामधुसंयुतम् ॥ ९२॥

तण्डुलीदकमित्येतत् प्रतिहितं प्रवाहिकाम् । कपिष्यविल्वमाणां कल्कानक्षसम्पत् पृथक् ॥ ९३॥

तथा कोमलमोचाद्यपि पिप्पली शृङ्गेरयोः । अथग्रन्थं भवेद्दन्तो (मधेद्वयो-शु० पा०) गोडमद्यकुलः खटः (डः) ॥ ९४॥

घृतसैर्द्वेण सहितः पीतो हति विरोधित्वात् । वाहिकां जीर्णभक्ष्यायाः प्राणस्य बलवर्धनः ॥ ९५॥ (का० सं० खि० १०)

२. फणितं तिलकल्कं च शर्करा मधुकं तथा । तण्डुलीदकसंयुक्तं सद्यो हति प्रवाहिकाम् ॥

काशमरीपृष्ठत्वक्कल्कं मिवत् ॥ (उपर्युक्त सदृश ही)

कितातितकं लोषं यष्टीमधुकमेव च । पातव्यं मधुसंयुक्तं सद्यो हति प्रवाहिकाम् ॥ (का० सं० खि० २/२-४)

३. प्रवाहिकायां गर्भिण्याः शस्तं सामे सशोणिते । आम्रजम्बूत्वचः क्वाथैर्हयेष्वन्नसक्तुकम् ॥

अनेन लोडमन्त्रेण गर्भिणी ग्रहणी जयेत् ॥ (यो० १० स्त्रीरोग वि०)

manāda (whey) mixed with little quantity of *ghrita* if used by pregnant woman suffering from *pravāhikā* gives relief.

(ii) Paste of *kirātārika*, *lodhra*, *madhyasī*, *phāṇia* (molasses) and *tila* mixed with sugar and honey taken with rice water cures *pravāhikā*.

(iii) A *khaḍā* (specific preparation) should be prepared with one *karṣa* paste of *kapitha*, *bilva*, *māsa*, *mocarasa*, *pippalī* and *śṛṅgavera* (ginger) each churning it with 1/2 *prastha* curd and wine made of jaggedry. Use of this with *ghrita* and honey after digestion of meals cures chronic *pravāhikā* and increases *prāṇa* (longevity) and *bala* (energy).

(vi) Use of *phāṇia*, paste of *tila*, sugar and *madhuka* with rice water cures *pravāhikā*.

(v) Use of *kirātārika*, *lodhra* and *madhyasī* with honey immediately cures *pravāhikā*.

(vi) Flour of parched paddy mixed with decoction of stem-bark of mango and black-berry taken by pregnant woman cures *pravāhikā* associated with *ama* (mucus) and blood. It also cures *grahāṇī* (sprue syndrome).

ग्रहणी चिकित्सा (Treatment of grahāṇī)

आम एवं जामुन की छाल के क्वाथ में लाजा का सत्व मिलाकर चाटने से गर्भिणी का ग्रहणी रोग नष्ट होता है^१। Flour of parched paddy mixed with decoction of stem bark of mango and black-berry cures *grahāṇī* (sprue syndrome).

अरुचि विकृति (Treatment of aruci or anorexia)

शृङ्गेर (आर्द्रक), कटुक तथा मातुलिङ्ग के केशर का दंत (मसूदे) एवं जिह्वा में मर्दन तथा उष्ण जल के साथ गण्डूष-धारण गर्भिणी को सभी प्रकार की अरुचि का निवारण करता है^१।

Massage of powdered *śṛṅgavera*, *kauka* and *keśara* (saffron) of *māṇuṅga* over teeth, (gums) and tongue followed by retention of mouthful hot water relieves all types of *aruci*.

विबन्ध चिकित्सा (Treatment of constipation)

त्रिफला-क्वाथ में हरीतकी, नागर तथा गुड़ मिलाकर शीतल करके पीने से गर्भिणी-स्त्री के विबन्ध तथा चिद्विध का नाश होता है^१।

Cooled decoction of *triphalā* mixed with *haritaki*, *nāgara* and *jaggery* cures constipation and abscess.

१. आम्रजम्बूत्वचः क्वाथैर्हयेष्वन्नसक्तुकम् ।

अनेनलोडमन्त्रेण गर्भिणी ग्रहणी जयेत् ॥ (भा० प्र० खि० ७०/६७, यो० १० स्त्रीरोग वि०)

२. शृङ्गेरं सकटुकं मातुलिङ्गस्य केशरम् । मार्जनं दन्तजिह्वसु गण्डूषक्षीण्यचारिणम् ॥ ७॥

गुर्भिणीनाञ्च सर्वसामलिवं च नियच्छति ॥ ८॥ (हो० सं० तुली० ५१/७८)

३. हरीतकी नागरं गुडेन वा त्रिफलाकषायः ॥ शीतः स्त्रीणां विनिहत्य पाने विबन्धविद्वेषीश्च ॥ (हो० सं० तुली० ५१/१०)

गर्भिणी के लिए दीपनीय औषधियाँ (*Dipaniya or appetizer drugs for pregnant woman*)

(१) पिप्पली, पिप्पलीमूल, मुस्ता तथा नागर (के चूर्ण) का शर्करा युक्त दुग्ध से पान^१ अथवा मधु मिलाकर क्षीर के साथ सेवन दीपनीय होता है^२।

(२) अजमोदा, नागर, पिप्पली तथा जीरक का सम भाग चूर्ण गुड़ एवं मधु के साथ खाने से गर्भिणी स्त्री को अग्नि दीप्त होती है^३।

(i) Use of powders of *pippali*, *pippalimūla*, *mustā* and *nāgara*, with milk sweetened with sugar or honey is appetizer.

(ii) Use of equal quantity of powder of *ajamoda*, *nāgara*, *pippali* and *jīraka* (cumin seed) with jaggery and honey increases appetite of pregnant woman.

गुल्म चिकित्सा (*Treatment of gulma*)

जो वातगुल्म तथा योनिगुल्म को चिकित्सा पूर्व में (सामान्य गुल्म एवं रक्तगुल्म चिकित्साध्याय में) संक्षेप में कह दी गई है (उसी विधि से उसे यहाँ भी प्रयुक्त करना चाहिए)। चतुर्थ मास में वातिक, वैतिक अथवा रसैयिक गुल्म को निम्न चिकित्सा करनी चाहिए^४।

महर्षि काश्यप का मत है कि मदनफल से युक्त घृत, अजपान, दूध अथवा इक्षुरस से यथावत् वमन करावे^५। स्वरस्य को इच्छा रखने वाला बुद्धिमान (वैद्य) चतुर्गुल से सिद्ध नससस या दुग्ध से विरेचन करावे^६।

प्लीक के (चो में) भुने हुए फलों या वाद्यालिका के पुष्प से बनी अम्ल (अनारदने मिश्रित) यकगू पीना चाहिए, जिससे (विरेचन के) अतिवश न हों^७।

Treatment of *vāta* and *yonigulma* described earlier (in *gulma* and *raktagulma cikisādhyāya*) should be used here also. However, medicines to be used during fourth month of pregnancy for the treatment of *vāyija*, *pitṛija* and *ślegmaja gulmas* are as follows: Emesis should be induced by giving *madanaphala* mixed with either *ghṛta*, edibles, drinkables or milk juice of sugarcane.

The wise physician should prescribe milk or meal soup medicated with *cauranmula* for purgation.

१. पिप्पली पिप्पलीमूल मुस्ता नागमेव च । दीपनीयं भिवेदितं परसा शर्कराश्लितम् ॥ (का० सं० चि० २/१३)

२. (पिप्पली) पिप्पलीमूलं मुस्ता लागमेव च (नागमेव च-यु० पा०) । दीपनीयं भवेदेतत् क्षीरेण तु समाक्षिकम् ॥ १४३॥ (का० सं० चि० १०)

(पाठ शोध का कारण यह है कि औषधियाँ रसादि एवं प्रभावदृष्ट्या सामञ्जस्य रखती हैं तथा चि० स्थान में गुणही हो जाति है)

३. अजमोदा नागरं च पिप्पली जीरकं समम् ॥ १३॥ तच्चूर्णं सगुडश्चैदं गर्भिण्या वह्निदीपनम् ॥ (यो० १० स्त्रीतो० चि०)

४. वातगुल्मस्य शैषस्य योनिगुल्मस्य चाप्यथ । यथावत् पूर्वमुद्दिष्टं समासेन चिकित्सितम् ॥ १४६॥

वातिके वैतिके चैव रसैयिके च विशेषतः । चतुर्थे मासि नागनागिनदं कुर्याच्चिकित्सितम् ॥ १४७॥

सागिभैरवागौर्वा क्षीरेणक्षुरसेन वा । वामयेत् फलपुकेन यथावद्विदितं कश्यपः ॥ १४८॥

चतुर्गुलमिदं रसेन पयसाऽपि वा । विरेचयेत् भस्मिन् य इच्छेत् सुखमासतः ॥ १४९॥

प्लीकामैतृद्वैर्वा पुषैर्वाद्यालकस्य वा । अम्लं यकगू प्रविशेन्नानिवेशा यथा भवेत् ॥ १५०॥ (का० सं चि० १०)

Sour (due to mixture of seeds of pomegranate) rice gruel medicated with fried (in *ghṛta*) leaves of *pūṭika* or flowers of *vāṭālika* should be given, so that she does not get excessive purgation.

गुदवेदना चिकित्सा (*Treatment of pain in anal region*)

गुदा से कष्ट पूर्वक रक्त आने पर एवं गुदा में वेदना होने पर कुष्मी (ताम्रादि निर्मित पात्र) अथवा पाप्माण (के पात्र) में तप्त दुग्ध का मधुक के साथ सेवन करना चाहिए तथा बाद में घृतमण्ड के द्वारा अनुवासन देना चाहिए^१।

For painful bleeding per rectum or pain in anal region the milk heated in *kuppi* (metal pot) or pot made of stone and mixed with *madhuka* should be prescribed followed by uncting enema of *ghṛta-manḍa* (The scum of melted butter).

परिकर्तिका चिकित्सा (*Treatment of parikartikā or anal fissure*)

(अ) सामान्य चिकित्सा (*General treatment*)

मधुरसा से युक्त (या साधित) मधु मिश्रित शीतल दुग्ध, शर्करा, मधु (मधुयष्टी) एवं तैल अथवा मधुयष्टी एवं फाणित (या सभी तीनों योग) लेहन करने से परिकर्तिका का नाश होता है अथवा व्याधि ठीक होती है^२। (औषध या द्रव्य नुसंक लिंग के शब्द है, अतः अन्तिम पीक में प्रयुक्त बहुवचन पुल्लिङ्ग शब्द सम्भवतः योगों के लिए आया है)।

Parikartikā is cured by use of either cold milk medicated with *madhurasā* and mixed with honey or mixture of sugar, *madhuyasī* and oil or *madhuyasī* and *phāṇita* (molasses).

(आ) वातिक परिकर्तिका चिकित्सा (*Treatment of vātika parikartikā*)--

जिस गर्भिणी स्त्री को वातिक परिकर्तिका हो जाए तो उसे बृहती, बिल्व तथा अनन्ता का यूथ बनाकर खाने को देना चाहिए^३।

Soup prepared with *bṛhātī*, *bilva* and *anantā* should be prescribed.

(इ) वैतिक परिकर्तिका चिकित्सा (*Treatment of patitika parikartikā*)

यदि गर्भिणी स्त्री को वैतिक परिकर्तिका हो जाय तो मधुक, हंसपादी तथा विरुजक को अच्छी प्रकार पीसकर मधु मिलाकर तण्डुलीक के साथ पीना हितकर होता है^४।

Finely powdered *madhuka*, *hansapādi* and *viturnaka* with honey followed by use of rice-water should be prescribed.

१. रक्तं निर्व्वा(व)हते यावत् कृच्छ्रात् सगुदवेदनम् । कुप्यपाणगतनेन परसा भोजितं ततः ॥ १०१॥

मधुकं घृतमण्डेन त्वष्ट्रेणानुवासयेत् ॥ १०२॥ (का० सं० चि० १०)

२. संयोज्य मधुना शीतं क्षीरं मधुरसाधिक(त)म् (मधुरसाश्लितम्-यु० पा०) । शर्करा मधु तैलं च यष्टीमधुकफणितम् ॥ एते हि लेहिता ज्वानि तथैव परिकर्तिकाः ॥ (का० सं० चि० २/१)

३. गर्भिण्या वातिकी यस्या जायते परिकी(क)र्तिका ॥ १०३॥

बृहतीबिल्वमाननैर्पूर्वं कृत्वा तु भोजयेत् ॥ १०३॥ (का० सं० चि० १०)

४. परिकी(क)र्तिकायां गर्भिण्याः वैतिकानिर्दं हितम् ॥ १०३॥

मधुकं हंसपादी च विरुजकमध्यापि च । पायवेन्मधुसंयुक्तं सुपिष्टं तण्डुलायुजा ॥ १०४॥ (का० सं० चि० १०)

(ई) रूतैषिक परिकर्तिका विकृतिता (*Treatment of śtaishmika parikartikā*)

रूतैषिक परिकर्तिका में कण्टकारी, श्वदंश तथा अक्षरथ (त्वक्) को समान मात्रा में लेकर नमक मिलाकर भोजन या पान के रूप में प्रयोग करना चाहिए^१।

Kanāḍakārī, śwadansyirā and aśwathā (stem bark) in equal quantity mixed with salt should be used either in solid or liquid form.

मुखपाक विकृतिता (*Treatment of stomatitis*)

यदि गर्भिणी स्त्री को मुखपाक हो जाय तो हृदि एवं दाहरीरि के कषाय का कवल धारण करना चाहिए। इसके पश्चात् स्नेह, बाद में शर्करा मिश्रित जल तत्पश्चात् लोष के कषाय का कवल धारण करे। तदुपान्त लोष के चूर्ण से ही प्रतिसरण करे। अन्त में अनन्ता, समझा (मंजिष्ठ), धृषी तथा मोचरस के चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करने से वह रुग्णा सुखी (स्वस्थ) हो जाती है^१।

If a pregnant woman suffers from stomatitis, she should hold mouthful of following substances in succession i.e. decoction of *haridrā* and *dāruharidrā*, fat (*ghrta*), water mixed with sugar and then decoction of *lodhrā*. After this, she should rub the powder of *lodhrā* and then take powders of *anantā*, *māñjishṭhā*, *dhṛṣṭī* and *mocarasa* mixed with honey.

पार्वग्रह चिकित्सा (*Treatment of pārsvagrāha or rigidity in flanks*)

यदि गर्भिणी स्त्री को पार्वग्रह हो जाय तो शालिपर्णी, बृहती, कण्टकारी, विल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, कारमरी तथा पाटला का भलीभाँति घूब बनाकर भोजन तथा पान में प्रयोग करना चाहिए^३।

Soup of *śāliparnī*, *pṛśniparnī*, *bṛhātī*, *kaṇṭakārī*, *blivā*, *agnimanthā*, *śyonāka*, *kāsmārī* and *pāḍalā* should be used with food and drinks.

गर्भिणी के आक्षेपक एवं अपतनक की विकृतिता (*Treatment of ākṣepaka and apatānaka or convulsive disorders of pregnant woman*)

(अ) असंयुष्ट दोष (केवल वातजन्य) होने पर विकृतिता (*Treatment of convulsions not associated with any other doṣa or caused by vāta only*)

आक्षेपक या अपतनक रोग के उत्पन्न हो जाने पर विडलवण तथा सैषव लवण मिलाकर मातुलुङ्ग के रस अथवा अग्निमन्थ या चरण के कषाय का पान करना चाहिए, अथवा लावा (बटे) या तिलिर का स्नेह युक्त मोसस प्रशस्त है।

१. रूतैषिकायां तु कर्तव्यं यथावन्निर्वाधत। कण्टकारी श्वदंश च अक्षरथं चेति तत् समम् ॥ १०५ ॥
सम्पन्नलवणं कृत्वा भोजयेत् पाययेदपि ॥ १०६ ॥ (का० सं० वि० १०)

२. अथ चेतनगर्भिण्या मुखपाको भवेद्विह ॥ १०८ ॥
हृदिद्रावलीषकाय ग्राहयेत् कवलं ततः। ततः स्नेहेन कृत्वा तु ततः स्याच्छर्करोदकम् ॥ १०९ ॥
लोषोदकेन कृत्वा तु कुर्यात्तद्विधारणम्। अनन्तं च समझां च धृषीं मोचरसं तथा ॥ ११० ॥
मधुना सह (म) मरनीयाततः सम्पद्यते सुखी ॥ १११ ॥ (का० सं० वि० १०)

३. अथ चेतन गर्भिण्याः पार्वग्रहोपग्रहो भवेत् ॥ १०६ ॥
शालपर्णी पुरिषपर्णी बृहती कण्टकारिका। विल्वानिमन्थश्योनाकं कारमर्ममथ पाटलिम् ॥ १०७ ॥
यवु कृत्वा तु सम्पन्नं भोजयेत् पाययेदपि ॥ १०८ ॥ (का० सं० वि० १०)

रीने के लिए वात-शामक औषधियों अथवा चाटूत (चर्मचट्टी) का रस देना चाहिए। यह विधि (अपतनक या अपतनक के) असंयुष्ट (वातदोषज) होने पर करने चाहिए^१।

The pregnant woman suffering from above disorders should be given any one of the following:

- (i) Juice of *māṭhulīngā* (lemon) mixed with *vidā* and rock salt.
- (ii) Decoction of *aguimanthā* or *varuṇā*.
- (iii) Soup of meat of quail or partridge mixed with fat.
- (iv) Juice/decoction of *vāḍilā* (*caruacai*) or the drugs capable of suppressing the *vāta*.

(आ) पित्तोपसृष्ट आक्षेपक या अपतनक विकृतिता (*Treatment of convulsions having association of pitta*)

यदि आक्षेपक एवं अपतनक में पित्त का संयोग हो तो जंगल मांसस मधुर करके अथवा मधुर वर्ग की औषधियों के कषाय को दाहिम (अनादना) से अम्ल करके देना चाहिए^३।

Sweetened meat soup of wild animals or decoction of drugs of *mādhura* group mixed with *dāḍima* (seeds of pomegranate) to make it sour, should be prescribed.

(इ) वात तथा रूतैष्योपसृष्ट आक्षेपक एवं अपतनक विकृतिता (*Treatment of convulsions having association of vāta with śtaishmā*)

जब इनमें (आक्षेपक या अपतनक में) वायु तथा रूतैष्या का संयोग हो तब अम्ल एवं कटु रस का प्रयोग करना चाहिए। यवक्षर युक्त जंगल मांसस का प्रयोग सदा हितकारी होता है। पित्तज के अतिरिक्त (वात एवं रूतैष्य संसां में) पाणिलाप से (हाथ को गर्म करके) मृदु ताप पहुँचाना लाभदायक होता है। जीर्ण गर्भ (गर्भावस्था की स्थिति बढी हुई होने पर) में विशेषकर घृत से सेक करना चाहिए। व्याधि के अनुसार यह सेक उष्ण या शीत प्रयोग करना चाहिए^३।

In above condition drugs of *amla* (sour) or *kaija* (hot) *rasa* should be prescribed. Use of meat soup of wild animals with *yavakṣārā* is beneficial. Mild fomentation with warmed palm is useful. Fomentation with *ghṛta* specially in late pregnancy is beneficial. Considering the status of disease hot or cold fomentation should be done.

१. आक्षेपके समुत्पन्ने तथैव्यपतनके ॥ १११ ॥

मातुलुङ्गरसः पयो विडसेभ्यजमयुतः। अग्निमन्थस्य निर्मृदुः क्वथितो चरणस्य वा ॥ ११२ ॥
लावो वा तैत्तिरो वाऽपि रसः श्लिष्यः प्रशस्तः। पणार्थं वातशमनो चाटूतो रस एव च ॥ ११३ ॥
असंयुष्टे तु कर्तव्यो विधिरैष सुजाहः ॥ ११४ ॥ (का० सं० वि० १०)

२. पित्तोपसृष्टे तु हितो जाङ्गलो मधुरो रसः ॥ ११४ ॥ शृतो मधुरकेः सर्वदाहिमन्थसमयुतः ॥ ११५ ॥ (का० सं० वि० १०)

३. वातश्लेष्मसमुत्पे तु व्यस्तसु कटुको रसः ॥ ११५ ॥
यवक्षरोप संयुक्तो जाङ्गलः सततं हितः। मृदवः पाणिलापाश्च पित्तवर्ज्ये हितस्तथा ॥ ११६ ॥
घृतसेकोऽथवा कर्णो जीर्णो गर्भे विशेषतः। उष्णो वा यदि वा शीतो व्याधिमसाह तत्ततः ॥ ११७ ॥ (का० सं० वि० १०)

गर्भिणी कामला चिकित्सा (Treatment of jaundice during pregnancy)

पिप्पली, अङ्गुठमूल, चोड़े की लीद का रस एवं पेंस (के दूध) का दही मिलाकर सेवन करना कामला रोग की चिकित्सा है^{१,३}।

पुश्पिपर्णी, बली तथा वासा का क्वाथ गर्भिणी के कामला रोग में लाभदायक है^१।

Use of *pippali* and root of *ankitha* mixed with juice of horse-dung and cura of buffalo's milk is beneficial.

Decoction of *pushpapari*, *balli* and *vasa* should be prescribed.

गर्भिणी हृच्छूल चिकित्सा (Treatment of cardialgia of pregnant woman)

(अ) वातिक हृच्छूल चिकित्सा (Treatment of cardialgia caused by vāta)

वातिक हृच्छूल में मातुलुंग के रस में भली मौति सैन्धव लवण मिलाकर पिलाना निश्चय रूप से प्रधान चिकित्सा है^१।

A potion of juice of *māṭuṅga* (lemon) mixed properly with rock salt is beneficial.

(आ) पैतिक हृच्छूल चिकित्सा (Treatment of cardialgia due to pitta)

पैतिक हृदयशूल में प्रियंगु, पिप्पली, भद्रमुस्ता, हरेणु, मधु तथा बदरी के चूर्ण का प्रयोग हितकारी होता है^१।

Powdered *pryangu*, *pippali*, *bhadramusta*, *harenu*, *badari* (junube fruit) and honey is beneficial.

(इ) श्लैष्मिक हृच्छूल चिकित्सा (Treatment of cardialgia due to ślegmā)

श्लैष्मिक हृदयशूल में पिप्पलीचूर्ण एवं पत्र, चोच तथा प्रियंगु के कल्क को मातुलुङ्ग के रस के साथ चारुने को देना चाहिये^१।

Powdered *pippali* with paste of *pātra*, *coca*, and *pryangu* mixed with juice of *māṭuṅga* (lemon) should be given.

नोट (Note)

उपर्युक्त सभी योगों का अन्यत्र महर्षि काश्यप ने गर्भिणी के सामान्य हृदय रोगों की चिकित्सा के लिए शब्दभेद से

१. पिप्पलच्छूठमूलानि वाजिलिण्डरसस्तथा ॥ १२७॥
दधि माहिसिलेत्त कामलायाश्चिकित्सितम् ॥ १२८॥ (का० सं० खि १०)
२. पिप्पलच्छूठमूलानि वाजिलेण्डरसं तथा । माहिशेष पिबेद्भजा कामलायां चिकित्सितम् ॥ (का० सं० वि० २/६)
३. पुश्पिपर्णीबलावासानियुङ्गे रकपित्तिज् । गर्भिण्याः कामलाशोफश्वासकासव्याहः ॥ (यो० १० स्त्रीयो० वि०)
४. मातुलुङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः ॥ १२८॥
वातिके हृदयशूले तुः प्रधान इति निश्चयः ॥ १२९॥ (का० सं० खि० १०)
५. प्रियङ्गुवोऽथ पिप्पल्यो भद्रमुस्ता हरेणवः ॥ १२९॥
क्षौद्रं बदरचूर्णं च पिबेत् पितादिले हृदि ॥ (का० सं० खि० १०)
६. पिप्पलीचूर्णकल्कस्तु पत्रं चोचं प्रियङ्गवः ॥ १३०॥
मातुलुङ्गरसश्चैव लेहः श्लेष्मादिले हृदि ॥ (का० सं० खि० १०)

गर्भिणी-व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा

वर्णन किया है केवल श्लैष्मिक शूलान्तरित वर्णित पिप्पली चूर्ण के स्थान पर पिप्पलीमूल (जो अधिक युक्तिमंगत है) तथा नोच एवं प्रियंगु के स्थान पर गन्धप्रियंगु शब्द का प्रयोग किया है^१।

Above medicines have been prescribed for general *hṛdṛoga* (cardiac disorders) by Kāśyapa at different place. However, there *pippali cūṇa* and *coca*, *pryangu* (described under *ślegmaja śūla*) have been substituted with *pippalimūla* and *gandhapryangu*.

कास चिकित्सा (Treatment of cough)

(अ) वातज कास चिकित्सा (Treatment of cough due to vāta)

कुलीरशृङ्गी, शरट (शु० पा०-मीच), भागी तथा पिप्पली (चूर्ण) का मातुलुङ्ग के रस के साथ बनाया हुआ लेह वातज कास को नष्ट करता है^१।

An electuary made with *kulīrasṅgī*, *māṭuṅga*, *bhāṅgī* and *pippali* mixed with lemon juice cures *vātajā kāsa*.

(आ) पित्तज कास चिकित्सा (Treatment of cough due to pitta)

मधूलिका, तुगाक्षीरी, पिप्पली, शर्करा तथा द्राक्षा का मधु के साथ मिश्रित लेह पित्तज कासहर है^३।

Licking of powdered *madhulika*, *tugākṣīrī*, *pippali*, *drākṣā* and sugar mixed with honey relieves *pittajā kāsa*.

(इ) श्लेष्मज कास चिकित्सा (Treatment of cough due to ślegmā)

पिप्पली, त्रिफला, रास्ता तथा भद्रदार के चूर्ण का मधु के साथ बनाया हुआ लेह कुशल चिकित्सकों द्वारा श्लेष्म कासहर कहा गया है^१।

An electuary made with powdered *pippali*, *triphalā*, *rāsta*, *bhadradārā* mixed with honey cures *ślegmaja kāsa*.

(ई) क्षतज कास चिकित्सा (Treatment of cough due to kṣata i.e. trauma)

मधुक, शङ्खपुष्पी, पीपल की लाख (शु० पा० जीवा या जीवन्ती एवं लाक्षा), मधु एवं शर्करा मिलाकर बनाया हुआ लेह क्षतज कास नाशक है^१।

१. मातुलुङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः । हृदि शूलस्य भेषजं श्लेष्मिन्याह कश्यपः ॥
पिप्पलीमूलकल्कस्तु पत्रं गन्धप्रियङ्गवः । मातुलुङ्गरसश्चैव हृदिशूलस्य भेषजम् ॥
प्रियङ्गुवोऽथ पिप्पल्यो भद्रमुस्तं हरेणवः । क्षौद्रं बदरचूर्णं च षडङ्गं हृदयौषधम् ॥ (का० सं० वि० २/१०-९)
२. कुलीरशृङ्गी शरटं (शु० पा० मीच) भागी पिप्पल्य एव च ॥ १३१॥
वातकासहो लेहो मातुलुङ्गरसस्तुतः ॥ (का० सं० खि० १०)
३. मधूलिका तु गोक्षीरी (शु० पा०-तुगाक्षीरी) पिप्पली शर्करा तथा ॥ १३२॥
द्राक्षाक्षौद्रसममधुको लेहो वै पित्तकासहा । (का० सं० खि० १०)
४. पिप्पल्यश्चिफला रास्ता भद्रदार समक्षिकम् ॥ १३३॥
श्लेष्मकासहोलेहः कुशलैः परिकीर्तितः ॥ (का० सं० खि० १०)
५. मधुकशंखचूर्णं च जीवालाक्षाश्च (शु० पा० जीवालाक्षाश्च) माक्षिकम् ॥ १३४॥
लेहः शर्करया युक्तः क्षतकासविनाशतः ॥ (का० सं० खि० १०)

Use of an electuary made with *madhuka*, *śankhāraspṛ*, *jīvā*, *lākṣā*, *sugāra* and *honey* cures *kṣatājā kāsa* (cough due to injury).

श्वस कास चिकित्सा (Treatment of dyspnoea associated with cough)

मधु, श्वित् एवं शल्यक (छोटी एवं बड़ी सारी) के रोम (मधु के पंख या चूँटे) तथा सारी के कटि, पिप्पलीतण्डुल (पिप्पली के टुकड़े) तथा कोलमूल (बेर की जड़) समान भाग लेकर चूर्ण करके मधु एवं सर्पि से लेहन करने से श्वस-कास का नाश होता है^१।

गुड़, गन्ना, पिप्पली, द्राक्षा, मरिच, हरिद्रा तथा समंगा (मंजिष्ठा) के चूर्ण को तैल के साथ चाटना श्वस, काम तथा तमक श्वास में श्रेयस्कर है^१।

अभय, आमलक, शल्यक त्वचा, गुहधूस तथा उड्ड की अस्थि (को भस्म) का दधि तथा तैल के साथ लेहन: अथवा पिप्पली, आमलकी, मुस्ता, फणिता, शर्करा तथा हरीतकी चूर्ण का मधु के साथ लेहन मभी प्रकार के कास एवं श्वस के प्रशमनाय प्रशस्त है^१।

हिकान्तर्गत वर्णित पिप्पल्यादि लेह श्वस में भी लाभदायक है^१।

भार्गी, शुण्ठी तथा कणा के चूर्ण का गुड़ के साथ सेवन श्वसकासहर है^१।

पूरिनपर्णी, बला तथा वासा का क्वाथ गर्भिणी के श्वसकास का नाश करता है^१।

Licking of equal quantity of powder of crescent spot of feather-tail of peacock, quill of both small and large variety of porcupine, *pippali* and *kolaṃbū* (root of jujube) with honey and *ghṛta* relieves dyspnoea and cough.

Use of jagger along with powders of *rāsnā*, *pippali*, *drākṣā*, *marica*, *haridā* and *sanānāgā* with oil is beneficial in dyspnoea, cough and *tanakāśvāsa*.

Licking of powdered *abhayā*, *āmalaka*, skin of porcupine (ash of skin), domestic soot and bone of camel (ash of bone) with curd and oil or powders of *pippali*, *āmalakī*, *masūā*, *phāṇiā*, *sugāra* and *haridākī* with honey is beneficial for relief of all types of dyspnoea and cough.

Pippalyādi leha described under *hikkā* (hiccup) is useful.

Use of powdered *bhānāgā*, *śunṭhī* and *kaṇā* with jagger cures dyspnoea and cough. Decoction of *prśnīparā*, *balā* and *vāṣā* cures dyspnoea and cough of pregnant woman.

१. मधुरात्रु रोमाणि श्वित्छरकयोर्गोपि ॥ १३५॥

पिप्पलीतण्डुलाश्चैव कोलमूलं च तसमम् । चूर्णितं मधुसर्पिभ्यां लिहेच्छ्वसकफाग्नम् ॥ १३६॥

गुडो रास्नाथ पिप्पल्यो द्राक्षा समरिचा तथा । हरिद्रा च समश्चर्णि चूर्णान्येवानि लेहयेत् ॥ १३७॥

तैलेन श्वसकासेषु तमके चैव पूजितः । अभयऽमलकं चापि शल्यकस्य त्वचाग्नम् ॥ १३८॥

अन्तर्यहं सरोक्षस्य दधिसेतेन लेहयेत् । पिप्पल्यामलकी मुस्ता तथा फणितशर्करा ॥ १३९॥

हरीतकीति चूर्णानि मधुसेतेन लेहयेत् । शमनं सर्वकामानां श्वासानां च प्रशस्तम् ॥ १४०॥ (का० सं० वि० १०)

२. का० सं० वि० २ (देखें हिकान्तर्गत)

३. भार्गीशुण्ठीकाणचूर्णं गुडैश्च श्वसकासहर ।

पूरिनपर्णीबलावासर्गिभ्यो ॥ गर्भिण्याः श्वसकास पदः ॥ (यो० २० त्रयो वि०; पृष्ठ ३८०)

ऊर्ध्ववात चिकित्सा (Treatment of short breath)

भद्रदारु, हरीतकी, सैधव, कुष्ठ, युत तथा फणित को मिलाकर लेहन ऊर्ध्ववात का नाश करता है^१।

Licking of *bhadravāra*, *haritākī*, rock salt, *kuṣṭha*, *ghṛta* and *phāṇiā* (molasses) cures short breath.

हिक्रा चिकित्सा (Treatment of hiccup)

पिप्पली, सैरिक, भार्गी, हिंगु, कर्कटकी के समान भाग के कल्क का मधु मिश्रित अथवा अमिश्रित लेहन करने से स्त्री की हिक्रा की शान्ति होती है^१। यह योग श्वस में भी लाभदायक है^१।

Use of electuary prepared with equal quantity of powders of *pippali*, *gairika* (red ochre) *bhātāngā*, *hingū*, *karṭikākī* with or without honey cures hiccup and is also beneficial in dyspnoea.

गर्भिणी मुखशोष चिकित्सा (Treatment of dryness of mouth)

वटप्ररोह, माषा, उशीर तथा घन की शर्करा मिलाकर बनाई हुई बटिका मुख में धारण करने से मुखशोष दूर होता है^१।

A pill prepared with *vaiṭaprarohā* (aerial roots of banyan tree), *magadhā*, *uśīra*, *ghana* and *sugāra* held in mouth cures dryness of mouth.

मूत्रग्रह चिकित्सा (Treatment of retention of urine)

शलावती, दर्भमूल, मधुक, क्षीरामोद, पाषाणभेद, उशीर तथा कतकफल (निर्मली के बीज) के क्वाथ या कल्क या इनमें साधित क्षीर का सेवन करने से सभी प्रकार के मूत्रग्रह में लाभ होता है, ऐसा महर्षि करण्य का मत है^१।

त्रयु तथा एवले के बीज, माषा, शिलाभेद तथा सिला को मिलाकर तण्डुलोदक के साथ पीना चाहिए । इससे गर्भिणी स्त्री का मूत्रशोष निश्चित ही शीघ्रता से निवारण हो जाता है^१।

Use of decoction or paste of *śalāvarī*, root of *darbhā*, *madhuka*, *kṣīramoḍā*, *pāṣāṇabheda*, *uśīra* and seeds of *katāka* relieves retention of urine; milk medicated with these drugs is also beneficial.

Powdered seeds of *ervārū* (snake-cucumber) and *tripuṣa* (cucumber), *magadhā*, *śilābheda* and *sugāra* if taken with rice water cure urinary retention.

१. भद्रदारुहरीतक्यौ सैधवं कुष्ठमेव च । घृतं च फणितं चैव लेह ऊर्ध्वानिलाग्रहः ॥ १४१॥ (का० सं० वि० १०) भद्रदारु । सफणितं घृतं चैव । (का० सं० वि० २११-उपसर्गक सदृश है)

२. पिप्पली गैरिकं भार्गी हिंगु कर्कटकी तथा । समानि च भवेत्तेहो हिक्राश्वसनः त्रिधा ॥ १४२॥ (का० सं० वि० १०) पिप्पल्यो । समाधिको भवेत्तेहो हिक्राश्वसनिर्बहणः ॥ (का० सं० वि० २१२, उपसर्गक सदृश)

३. वटप्ररोहं माषामुशीरं घनमेव च । युतं खण्डगुटिकास्ये विहिता शोषकारिणी ॥ (हा० सं० तुली० ५१/२, ३)

४. शलावती दर्भमूलं मधुकं क्षीरामोदः । पाषाणभेदकोशीरं कतकस्य फलानि च ॥ १४४॥

एषा क्वाथपरसं कल्कं क्षीरं वा पायसेन्द्रियम् । मूत्रग्रहेषु सर्वेषु सिद्धमिषाह करण्यः ॥ १४५॥ (का० सं० वि० १०)

५. मूत्रविवचनस्य त्रयुवैरि (त्रयुवैरि-शु० पा०) बीजानि माषा च ॥

शिलाभेदं सिलाब्जश्च पिबेत्तण्डुलवारिणः । मूत्रशोषं गुर्विणीनां वायस्यशु निश्चितम् ॥ (हा० सं० तुली० ५१/१२)

शोफ चिकित्सा (Treatment of edema/inflammation)

(अ) आभ्यन्तर प्रयोग (Oral use)

वर्षाभूमूल के क्वाथ में देवदार तथा मूला अथवा केवल भद्रदार मिलाकर मधु युक्त करके शोफ युक्त स्त्री को पान करना चाहिए^१।

पुश्पिन्पर्णी, बला तथा वासा का क्वाथ गर्भिणी के शोफ का नाशक है^२।

Decoction of roots of *varṣābhū* mixed with paste of *devadāru* and *mūlā* or only *bhadrādāru* along with honey cures *śōpha*.

Decoction of *pūshpīparṇī*, *balā* and *vāsā* relieves *śōpha*.

(आ) बाह्य प्रयोग (External application)

गन्ध के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न शोफ में उष्ण जल से स्वेदन करें^३।

चन्दन, मधुक, उशीर, नागकेसर, तिल, अजशृंगी, मंजिष्ठा, रविमूल तथा पुनर्नवा से निर्मित लेप शोफ नाशक होता है, विशेषकर गर्भिणी स्त्री को लाभदायक है^४।

Sudation with hot water should be used in cases of *śōpha* developing as a complication of pregnancy.

An ointment made of *candana*, *madhuka*, *uśīra*, *nāgagrapasa*, *tīla*, *ajāśṛiṅgī*, *mañjishṭhā*, root of *ravi* and *punarṇavā* is beneficial.

(इ) शोफ में निषेध (Contraindication in śōpha)

बुद्धिमान वैद्य को शोफ में दारुण विरेचन नहीं देना चाहिए^५।

Wise physician should never prescribe strong purgatives in *śōpha*.

त्वचागत वातरोग चिकित्सा (Treatment of skin disorders due to vāta)

त्वचागत वातरोग में सैन्धव त्वण मिश्रित स्निग्ध मांसरस अथवा षष्टिक चावल माहिषी के खट्टे दही के साथ मिलाकर पथ्य है^६।

Unctuous meat-soup mixed with rock salt or *śaṣṭikā* rice with sour curd made of buffalo's milk is congenial.

१. वर्षाभूमूलनिकम्बधं योजयेद्देवदारुणा । तत् पिबेन्मधुसंयुक्तं शूना स्त्री मूर्कया सह ॥ (का० सं० चि० २/५)

वर्षाभूमूलनिकम्बधं योजयेद्भद्रदारुणा ॥ १२६॥

तत् पिबेन्मधुसंयुक्तं शोफं स्त्री पूर्वया सह ॥ (का० सं० चि० १०)

२. पुश्पिन्पर्णी पथः ॥ (यो० १० स्त्री० १० चि०, पृष्ठ २८०)

३. गर्भस्योपद्रवाः शोफाः स्वेदयेदुष्णवारिणा । न दातव्यो मतिसत्ता विरेको दारुणो महान् ॥ (हा० सं० तुली० ५१/१३)

४. चन्दनं मधुकोशीरं नागपुष्पं तिलास्तथा ॥

अजशृङ्गी च मंजिष्ठा रविमूलं पुनर्नवा । श्रेष्ठः शोफहरो लेपो गर्भिणीनां विशेषतः ॥ (यो० १० स्त्री० चि०)

५. स्निग्धो मांसरसः पथ्यः सैन्धवेनावचूर्णितः । माहिषे षष्टिका चापि स्यादस्ते त्वधि मारते ॥ (का० सं० चि० २/१०)

अन्य वातरोग चिकित्सा (Treatment of other vāta disorders)

क्वित्त्व, अग्निमन्थ अथवा पाटला एवं नागर से मिश्र एवं शीतल किया हुआ जल (क्वाथ) गर्भिणी स्त्री के वातविकारों का नाशक होता है^१।

एण्डपत्रों को दुग्ध के साथ (पत्रचूर्ण को दुग्ध के साथ या दुग्ध में एण्डपत्र पका कर) वातरोग-पीड़ित स्त्री को देना चाहिए^२।

Cooled decoction of *bīḥva* and *aguṇimanthā* or *pālāla* and *nāgara* cures *vāta* disorder. Powdered leaves of *eraṇḍa* with milk or milk medicated with leaves of *eraṇḍa* is beneficial.

रक्तपित्त चिकित्सा (Treatment of bleeding diathesis)

पुश्पिन्पर्णी, बला तथा वासा का क्वाथ गर्भिणी के रक्तपित्त को नष्ट करता है^३।

Decoction of *pūshpīparṇī*, *balā* and *vāsā* cures *raktapīṭta* (bleeding diathesis).

विद्रव्य चिकित्सा (Treatment of abscess)

हरीतकी, नागरक तथा त्रिफला के शीतल क्वाथ में जुड़ मिलाकर पीने से विद्रव्य का नाश होता है^४।

Cooled decoction of *haritakī*, *nāgaraka* and *trīphalā* mixed with jaegery cures abscess.

विष या सर्पदंष्ट्र चिकित्सा (Treatment of poisons or snake bite)

(अ) वमन (Use of emetics)

है नृप । जिस स्त्री को सर्प ने काट लिया हो, या उसने कोई विष पी लिया हो तो उसकी विषनाशक औषधियाँ द्वारा वमन कराकर तत्पश्चात् संसर्जन क्रम द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए^५।

If the pregnant woman has taken some poison or has been bitten by snake, the emetics should be induced by drugs possessing qualities aganist *vīṣas* (poisons). This should follow specific regulated dietetic regimen.

(आ) आभ्यन्तर प्रयोगार्थ औषधियाँ (Oral medicines)

पाठा, अमृता, सोमवल्क (खेत खदिर), दोनों सह (क्षुद्रमहा, महासहा) तथा कुटज के साथ क्वथित क्षीर का पान स्त्री के विष को नष्ट करता है^६।

शिरिष, पाटलीमूल, तण्डुलीयक, सिन्दुवाति (मिर्गुडी) एवं सहचर की मूल के क्वाथ से साधित पाली पेय विष का नाश करती है^७।

१. किल्लीनिममथयववं वा पाटल्या नागरेण वा ॥ सिद्धमन्त्रु भिक्व्छीतं गर्भिणी वातरोगमुत् ॥ (यो० १० स्त्री० चि०)

२. एण्ड (पत्र) क्षीरेण वातरोगिन्त्रला भिक्वत् ॥ १५१॥ (का० सं० चि० १०)

३. पुश्पिन्पर्णी पथः ॥ (यो० १० स्त्री० चि०, पृष्ठ २८०)

४. हरीतकी नागरकं गुडेन वा त्रिफलाक्वाथः । शीतः स्त्रीणां विनिहितं पाने विषन्वं विद्रव्यांश्च ॥ (हा० सं० तुली० ५१/१०)

५. दद्या सर्वेण पीता वा या विषं गर्भिणी नृप ॥ १५५॥

वमनार्थिर्विषजैस्तु संयुष्टः स्यादुपक्रमः ॥ १५६॥ (का० सं० चि० १०)

६. पाठाऽमृता सोमवल्कं द्वे सहै कुटजं तथा ॥ १५६॥

क्षीक्रीधितमेतच्च पेयं नार्था विषाहम् । शिरिषं पाटलीमूलं तण्डुलीयकमेव च ॥ १५७॥

सिन्दुवारिमूलं च मूलं सहचरस्य च । निक्व्वाध्य साधयेत् पेयां प्रभुदां विषनाशनम् ॥ १५८॥ (का० सं० चि० १०)

Use of milk, boiled with paste of *pāṭhā*, *amrītā*, *sonmarvaka*, *ksudhrasahā*, *mahāsahā* and *kuija* destroys poisons.

A drinkable prepared with decoction of *śiṛiṣā*, *pāṭhāmlā*, *tanḍulīyaka*, root of *sindūrīnī* and *śahacāra* destroys poisons.

(इ) सिरावेधका निषेध (Contraindication for venesection)

महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट का मत है कि गर्भिणी को सर्पदंष्ट होने पर उसका सिरावेधन नहीं करना चाहिए, अन्य वर्णित मृदु चिकित्सा करनी चाहिए ।

In event of snake bite to a pregnant woman, venesection should not be done, only *mṛdū* (gentle) drugs or measures prescribed for snake bite should be used.

(ई) पथ्य (Dietetic regimen)

खट्व्यूष आदि तथा युक्तिपूर्वक सेवन किया गया अन्न हितकारी है, तथा अन्यत्र (विष चिकित्सा में) भी जो वर्णित है उसका प्रयोग करना चाहिए ।

Use of *khada* (a sweet dish), soup and properly prepared cereals are beneficial; the treatment for poisons prescribed at other places should also be used.

गर्भदाह (Pregnancy heart-burn)

गर्भदाह होने पर उष्णोदकानुपान अपथ्य होता है ।

Hot water should not be given in case of pregnancy heart-burn.

गर्भिणी को स्वयं या उसके गर्भ को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण (Bad prognostic signs/symptoms likely to injure mother or fetus)

गर्भिणी स्त्री की व्याधियों की विशिष्ट चिकित्सा वर्णन के उपरान्त महर्षि काश्यप ने गर्भिणी स्त्री के कुछ अरिष्ट लक्षणों का वर्णन किया है । गर्भिणी को कोई भी व्याधि होने पर उसका प्रभाव सर्वप्रथम गर्भ पर पड़ता है, इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही सम्भवतः महर्षि काश्यप ने तीन मुख्य वर्गों के अरिष्ट लक्षणों का वर्णन किया है (१) गर्भ को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण अर्थात् इन लक्षणों से युक्त गर्भिणी के गर्भ का पात हो जाता है अर्थात् गर्भ नष्ट हो जाता है । (२) उत्पन्न हुए पुत्र को नष्ट करने वाले अरिष्ट-लक्षण अर्थात् इन लक्षणों से युक्त स्त्री का उत्पन्न हुआ पुत्र मर जाता है, सम्भवतः ये अरिष्ट लक्षण अधिकांशतः गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में होने वाली व्याधियों में होते हैं, अथवा इन लक्षणों का तत्काल गर्भ में कोई नाशक प्रभाव न हो कुछ ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि वह उत्पन्न होने के बाद बाह्य जलावरण में जीवित न रह सकता हो अतः पुत्र की मृत्यु हो जाती हो । (३) गर्भिणी के स्वयं को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण, उपर्युक्त दोनों वर्गों के अरिष्ट लक्षणों में गर्भिणी पर कोई भी विनाशक प्रभाव नहीं होता, परन्तु तीसरे वर्ग के अरिष्ट लक्षण स्वयं गर्भिणी के ही नाश के द्योतक होते हैं ।

१. (अ) गर्भिणी बालवृद्धानां सिरावधनवर्जितम् ॥ ३० ॥

विषातानां यथोद्दिष्ट विधानं शस्यते मृदु ॥ (सु० सं० ५/३०, ३१)

(आ) गर्भिणी बालवृद्धेषु मृदु विष्येत् सिराञ्च न ॥ (अ० सं० ३० ४२/५६)

२. खट्व्यूषादिकं चापि युक्त्याऽन्नमशितं हितम् । द्वितीये वक्ष्यते यच्च स्थाने तच्चापि कारयेत् ॥ १५९ ॥ (का० सं० छि० १०)

३. नोष्णोदकं भवेत् पथ्यम् । पित्ते रक्तलावे गर्भयवने च गर्भदाहे च ॥ (का० सं० सू० २२/१४)

यद्यपि इसी संदर्भ में कतिपय अन्य अरिष्ट लक्षणों का भी वर्णन है, परन्तु उनका मूलागम से सम्बन्ध होने के कारण यथास्थान वर्णन किया जायगा ।

After describing the treatment of various disorders afflicting a pregnant woman Kāśyapa has mentioned certain signs/symptoms, presence of which indicates bad prognosis. These can be classified under three categories:

- Signs/symptoms likely to injure the fetus or in other words if pregnant woman exhibits these, the fetus will either die or get aborted.
- Signs/symptoms in presence of which born child dies. It is just possible that these signs/symptoms might be appearing in third trimester of pregnancy but do not cause immediate danger to the fetus, however, produce some such abnormality that neonate is unable to survive in new environment.

- In first two categories though clinical features appear in mother, yet do not harm her, but clinical features of third category show bad prognosis for the pregnant woman herself.

(१) गर्भ को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण (Clinical features indicating possible intrauterine death of the fetus or abortion)

गर्भिणी दुर्बलकाया या भवत्यसिता सती (शु० पा० भवत्यधिकशाना) ।

चरश्चाभिद्रवत्येतां तस्या गर्भो विपद्यते ॥ १६० ॥

बहु भुङ्क्ते तु याऽत्यर्धं बहुशो बहुमूर्च्छिता । भवेत्तस्याः पलेद्गर्भो गर्भिण्यास्तु न संशयः ॥ १६१ ॥

नेत्रे मुस्तोत्थिताकारे कर्णौ पादौ च शीतलौ । केशाश्च जटिला यस्यास्तस्या गर्भो विपद्यते ॥ १६२ ॥

उपरिष्टस्तु यो नाभ्या उभे पार्श्वे निषेवते । मध्ये वा तिष्ठते नार्याः सोऽपि गर्भो विपद्यते ॥ १६३ ॥

रुक् सन्ध्यांशे यस्याः स्यान्मण्डले चालिचिस्तथा । निश्छेद्यस्त्रनकाभायास्तस्या गर्भो विपद्यते ॥ १६४ ॥

(का० सं० छि० १०)

जो दुर्बल आकार की गर्भिणी स्त्री एकदम खूबे वर्ण की (अत्यधिक पाण्डु के कारण खूबे) तथा चर से पीड़ित होती है, उसके गर्भ का नाश हो जाता है । शुद्ध पाठ में स्त्री दुर्बलकाया, अत्यधिक खाने वाली अर्ध हो जायेगी ।

जो स्त्री बार-बार बहुत ज्यादा खाती है तथा बार-बार मूर्च्छित हो जाती है, उस गर्भिणी के गर्भ का पात हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ।

जिस स्त्री के नेत्र मोथे के समान उठे हुए (अत्यधिक नेत्र-शोफ), कर्ण एवं पैर शीतल तथा केश जटिल या आपस में चिपके हुए हों उसका गर्भ नष्ट हो जाता है ।

जो गर्भ स्त्री की नाभि के दोनों पार्श्वों में अथवा मध्य में स्थित होता है, वह भी नष्ट हो जाता है ।

जिस स्त्री के सन्धि-बन्धनों में पीड़ा हो, भोजन में अलवि हो, निश्छेद (सदृश) हो अथवा अत्यधिक सोने की इच्छा करती हो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है ।

A scraggy pregnant woman, who is white in complexion or eats too much and suffers from fever, her fetus dies in uterus.

A pregnant woman who eats frequently in large quantity and becomes repeatedly unconscious definitely gets abortion.

The woman whose eyes are swollen, ear and feet cold and hair matted, her fetus gets destroyed (dies in uterus).

The fetus who is situated either on both lateral sides of umbilicus (of mother) or in centre of abdomen also dies (in uterus).

The pregnant woman who suffers from pain of joints, anorexia, drowsiness and always wants to sleep, her fetus dies in uterus.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णित पाँचों श्लोकों का पृथक् पृथक् विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अत्यधिक पाण्डुता, दूसरा प्रमेह (क्योंकि अत्यधिक भोजन एवं मूँछों लक्षण है), तीसरा वृक्कशोथ (क्योंकि आँखों में शोफ लक्षण है) का द्योतक है। इन तीनों ही स्थितियों के गर्भभर होने पर अधिकांशतः गर्भस्त्राव हो ही जाता है। चौथे श्लोक में संभवतः आचार्य ने गर्भशोथ के जन्मजात विकारों की ओर इशारा किया है। पाँचवाँ श्लोक सम्भवतः संधिशोथ का वर्णन है। यद्यपि संधिशोथ के उपद्रवों में गर्भपात का आधुनिक काल में वर्णन नहीं मिलता, परन्तु हो सकता है कि अति आतापीक अवस्था में गर्भपात हो जाए।

Out of five verses mentioned above probably first hints towards excessive anaemia, second to diabetes mellitus (as excessive eating and unconsciousness are the clinical features) and third to nephritis or toxæmia of pregnancy (edema around the eyes is a sign). In all the above three conditions, if these turn serious, abortion is inevitable. Fourth verse probably indicates some congenital abnormality of uterus and the fifth to arthritis. Though normally arthritis does not cause abortion or intrauterine death of fetus, however, in acute conditions these complications may happen.

(२) उत्पन्न हुए पुत्र को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण (Clinical features indicating possible death of the child)

संधिशोथोद्भूपाकश्च विक्रमश्च गुरुर्भवेत् । यस्यास्तस्याः सुतो जातो ध्रियते नात्र संशयः ॥ १६५ ॥

शोचस्त्याः परिदेविन्याः प्रथ्यादिव्यास्तथैव च । अङ्गुलीर्मोदशीलाया जातः पुत्रो न जीवति ॥ १६६ ॥

दुर्गन्धि च पयो यस्या जटिलाश्च शिरोरहाः । मलिनाश्च ततस्तस्या जातः पुत्रो न जीवति ॥ १६७ ॥

(का० सं० खि० १०)

जिस स्त्री को संधियों में शोथ, अङ्गों का पाक तथा पादव्यास गुरु (चलने में भारीपन) हो जाए, उसका उत्पन्न हुआ पुत्र मर जाता है, इसमें संशय नहीं है।

जो स्त्री (गर्भावस्था में) शोक, विलाप तथा चिन्तन करती हो, तथा नित्य अंगुली-स्फोटन (उँगली चटकाना) करती रहती हो, उसका उत्पन्न हुआ पुत्र जीवित नहीं रहता।

जिसका स्तन दुर्गन्धि युक्त एवं सर के बाल जटिल (जटा स्वरूप आपस में चिपके हुए) तथा (शरीर) मलिन हो, उसका उत्पन्न हुआ पुत्र जीवित नहीं रहता।

The pregnant woman who suffers from arthritis, suppuration of body parts (multiple

abscess or generalised pyæmia) alongwith heaviness of gait, her born child dies without any doubt.

The pregnant woman who is sad, bewailing, subtly speculating and always cracking her fingers, her born child can not survive.

The woman who has foul smelling milk secretion, matted hair and is very dirty, her born child can not survive.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त तीनों श्लोकों में उत्पन्न हुए पुत्र की मृत्यु का कारण क्रमशः शारीरिक, मानसिक एवं स्तन व्याधियों को बताया है।

Above mentioned three verses denote physical, psychological and breast milk abnormalities respectively.

(३) गर्भिणी को ही नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण (Clinical features denoting possible death of pregnant woman)

पाण्डुरशूलं च तुष्णा च संज्ञानाशस्तथैव च । श्वासश्च कर्मशेषश्च यस्याः साऽपि न जीवति ॥ १७० ॥

कटिग्रहो योनिशूलं पूतिगन्धि मुखं तथा । संज्ञानाशः प्रलापो वा गर्भिण्याः सा न जीवति ॥ १७१ ॥

रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमास्त्यानुलेपना । मयते सा शयाना वा श्मशानं यादियरोहति ॥ १७४ ॥

मूढगर्भा सर्गर्भा वा गर्भिणी सा विनश्यति । खरं वराहं महिषं श्वानमुष्ट्रं तथैव च ॥ १७५ ॥

स्वप्नेऽपिरोहते वा तु सर्गर्भा सा विनश्यति ॥ (का० सं० खि० १०)

जिस स्त्री को पाण्डुरशूल, तुष्णा, संज्ञानाश, श्वास तथा सोतम् (प्राणवह) का अवरोध हो जाए, वह स्त्री जीवित नहीं रहती।

जिस गर्भिणी स्त्री को कटिग्रह, योनिशूल, मुख से पूतिगन्धि, संज्ञानाश तथा प्रलाप हो जाए, वह जीवित नहीं रहती। जो मूढगर्भा जाती या (सामान्य) गर्भ युक्त गर्भिणी रक्तवर्ण के वस्त्र पहनती हो, रक्त वर्ण की मालायें तथा अनुलेपन धारण करती हो, सोते हुए मुस्कुराती हो तथा श्मशान की ओर जाती हो, वह नष्ट हो जाती है अर्थात् मर जाती है।

जो गर्भवती स्त्री स्वप्न में खर, वराह, महिष, श्वान एवं कैट की सवारी करती है, वह नष्ट हो जाती है।

The pregnant woman suffering from pain in flanks, thirst, unconsciousness, dyspnoea and obstruction of *svotassas* (*prāṇavaha svotassas* i.e. respiration) does not survive.

The pregnant woman having stiffness of sacral region, pain in vagina, putrid smell from mouth, unconsciousness and delirium does not survive.

The pregnant woman either normally pregnant or having *mūḍha garbha* (obstructed labour), who wears red garments and garlands, uses red anointments, smiles during sleep and goes towards cremation ground does not survive.

The pregnant woman who dreams of riding over donkey, hog, buffalo, dog or camel does not survive.

गर्भजन्य विषमयता (Toxaemia of pregnancy)

गर्भिणी को व्याधियों में गर्भजन्य विषमयता एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याधि है, विशेषकर सायनासाध्यता की दृष्टि से, क्योंकि गर्भिणी एवं गर्भ की मृत्यु का यह एक मुख्य कारण है। आधुनिक विज्ञान की पुस्तकों में वर्णित विस्तृत विवेचना को न देते हुए आयुर्वेदिक संहिताओं में उपलब्ध यत्रत्र वर्णित विषय को शृंखलाबद्ध कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

गर्भजन्य विषमयता में मुख्य तीन लक्षण होते हैं (१) भार वृद्धि या शोफ (२) मूत्र में एल्ब्युमिन का आना (३) रक्तचाप-वृद्धि। इन लक्षणों के अतिरिक्त कतिपय गौण लक्षण जैसे अति वमन, कभी-कभी अतिसार, शिरःशूल एवं भ्रम आदि भी होते हैं। यदि उपर्युक्त लक्षणों की स्थिति में व्याधि की उचित व्यवस्था न की गई तो अंत में आक्षेप या मूर्छा की स्थिति हो जाती है, एवं व्याधि अति कष्टसाध्य हो जाती है।

स्त्री के प्रधान एवं गौण उपर्युक्त लक्षणों में मूत्र में एल्ब्युमिन तथा रक्तचाप वृद्धि की उपस्थिति का निर्णय चिकित्सक करता है। आयुर्वेदिक संहिताओं में व्याधियों का वर्णन मुख्यतः रोगी के द्वारा वर्णित लक्षणों या दर्शन परीक्षा द्वारा ज्ञातव्य करता है। आधार पर किया गया है, अतः गर्भिणी शोफ एवं आक्षेप तथा मूर्छा का वर्णन ही मुख्यतः द्रष्टव्य है। साथ लक्षणों के ही आधार पर किया गया है, अतः गर्भिणी शोफ एवं आक्षेप तथा मूर्छा का वर्णन ही मुख्यतः द्रष्टव्य है। साथ ही अन्य आनुवंशिक लक्षणों के वर्णन पर भी एक दृष्टिपात करना होगा।

Though toxemia of pregnancy as a disease entity has not been described in *ayurvedika* classics, a few scattered references when put together give the idea about this entity

This entity is characterized with : (i) increase in weight or edema, (ii) presence of albumin in urine, (iii) hypertension. Besides these cardinal features other associated symptoms such as excessive vomiting, headache, giddiness, sometimes diarrhoea are also present. Out of all these, presence of albumin in urine and rise in blood pressure probably were not known, however other features have been described.

आनुवंशिक लक्षणों का वर्णन (Description of associated symptoms)

(१) वमन (Vomiting)

गर्भिणी छर्दि का विस्तृत वर्णन पूर्व पृष्ठों में दिया जा चुका है।

It has already been described earlier.

(२) अतिसारादि अन्य लक्षण (Diarrhoea, hiccup etc.)

अतिसार, हिकका एवं खवास आदि की लाक्षणिक चिकित्सा महर्षि काश्यप ने विस्तृत रूप से वर्णन की है जो पूर्व वर्णित है।

Management of diarrhoea, hiccup, dyspepsia etc. has been given in preceding pages.

(३) मूत्रालयता (Oliguria)

मूत्रालयता वास्तव में शोफ के कारण होती है, क्योंकि शारीरिक जल त्वचा एवं मांसतार्त एकर होने लगता है तथा मूत्र द्वारा नहीं निकलता, अतः यह शोफ का उत्पलक्षण है, न कि स्वयं में कोई व्याधि। महर्षि काश्यप एवं हारीत ने मूत्रग्रह की चिकित्सा का भी वर्णन किया है।

Due to edema the fluid is retained in the body resulting into oliguria, thus it is actually a sequela, not an independent sign. The treatment of oliguria (caused due to retention of fluid in the body resulting in edema) has also been given.

मुख्य लक्षणों का वर्णन (Description of cardinal features)

लक्षणों में तीन ही मुख्य हैं शोफ, आक्षेप एवं भ्रम या मूर्छा।

Śopha (edema), *ākṣepa* (convulsions) and *murchā* (unconsciousness) have been mentioned.

(अ) शोफ (Edema)

(१) महर्षि हारीत ने गर्भ के आठ उपद्रवों में शोफ एक उपद्रव माना है^१।

(२) यद्यपि महर्षि वाग्भट ने व्यक्तगर्भ के लक्षणों में पादशोफ एक लक्षण वर्णित किया है परन्तु इसे गर्भजन्य विषमयता के अन्तर्गत लेना उचित नहीं होगा। शोफ व्याधि में निज शोफ के निदानों का वर्णन करते समय महर्षि चरक एवं वाग्भट ने गर्भोत्पीडन से शोफ की उत्पत्ति का एवं विषम प्रसूति जन्य शोफ का (सभी आचार्यों ने) वर्णन किया है^३। यद्यपि गर्भपात या विषम प्रसूति के बाद उत्पन्न शोफ गर्भजन्य विषमयता का लक्षण नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रसव के बाद आक्षेप आदि लक्षण उन्हीं स्त्रियों की होते हैं, जिन्हें शोफादि गर्भावस्था से ही उपस्थित हों पर गर्भजन्य शोफ की विषमयता का लक्षण मान सकते हैं।

(३) गर्भिणी की व्याधियों की विशिष्ट चिकित्सा का वर्णन करते समय शोफ चिकित्सा का वर्णन^३ तथा अष्टि लक्षणों में भी शोफ का नामोल्लेख महर्षि काश्यप ने किया है^४।

- Hārta has included *śopha* in the list of complications during pregnancy,
- Vāgbhata* has included mild edema of feet as a sign of pregnancy, and edema is said to develop after abortion or abnormal labour also, but these do not denote toxemia, however, in the etiology of the disease *śopha* Caraka and *Vāgbhata* have included *garbha* (pregnancy) also as a cause of endogenous edema or in other words pregnancy can cause pathological edema.
- Specific treatment of *śopha* has been given by Kāśyapa. *Śopha* is also included in the list of features denoting bad prognosis.

१. हारो सं० तृतीय ५१/१ (पृष्ठ २४१)

२. (अ) निजः पुनः लवणातिभक्षणद्याभसंघाडनादमाभप्रतनात् प्रजालानां च मिथ्योपवागादुदीर्घदोषत्वाच्च शोफः प्रादुर्भवति ॥ (च० सं० सू० १८/६)

(आ) शूलजन्माशयक विषमा प्रसूति । निजस्य हेतुः स्वयंशोः प्रदिष्टः । (च० सं० चि० १२/५ च ६ एवं मा० नि० ३६/४ च ५)

(इ) व्याधिकर्णोवासादि अशौं जटस्यदत्त्वाः । गर्भवीसर्पपाण्डवः ॥ (अ० सं० नि० १३/२७ से ३०)

(ई) रजसकसासितसाराशौं जटस्यदत्त्वाः । गर्भवीसर्पपाण्डवः ॥ (अ० सं० नि० १३/२७, २८)

३. का० सं० चि० २/५, चि० १०/१२६; हारो सं० तृतीय ५१/१३ एवं यो० १० खी० तै० चि० (पृष्ठ २८८)

४. का० सं० चि० १०/१६२ (पृष्ठ २८७)

(आ) आक्षेप (Convulsions)

(१) महर्षि कारश्यप ने गर्भिणी के आक्षेपक एवं अपतनक को विशिष्ट चिकित्सा का निर्देश किया है, यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि ये आक्षेप गर्भ के ही कारण होते हैं फिर भी गर्भिणी में वर्णित होने के कारण इस वर्णन को गर्भजन्य विषमयता का अप्रत्यक्ष उदाहरण मान सकते हैं।

(२) महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने असाध्य मूढगर्भा के अनेकों लक्षणों में आक्षेप को भी एक लक्षण माना है^१। यद्यपि यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि ये आक्षेप गर्भजन्य विषमयता के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से भी हो सकते हैं, फिर भी असाध्यता का लक्षण होने के कारण इसे भी गर्भजन्य विषमयता के अन्तर्गत ले सकते हैं, क्योंकि यह तो प्रमाणित तथ्य है कि प्रसव के समय प्रारम्भ होने वाले आक्षेप प्रसव के अवरोधकारक एवं मातृ तथा शिशु के लिए अधिकशतः घातक होते हैं।

i) Kāśyapa has prescribed treatment for convulsive disorders.

ii) Suśruta and Vāgbhaṭa have included *ākṣepa* (convulsion) as a sign of bad prognosis in cases of obstructed labour.

(इ) भ्रम एवं मूर्छा (Giddiness and unconsciousness)

मूर्छा लक्षण का गर्भावस्था में स्पष्ट उल्लेख केवल महर्षि वाग्भट ने व्यक्तगर्भा के लक्षणों में किया है, जो सम्भवतः गर्भावस्था में नाड़ीबल संस्थान के उत्तेजित होने से कभी-कभी उत्पन्न क्षणिक मूर्छा का वर्णन है, न कि गर्भजन्य विषमयता का। विपरीत दृष्टिकोण संयोग तथा भ्रम आदि लक्षणों को भी महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने मूढगर्भा की असाध्यता के लक्षणों के अन्तर्गत वर्णित किया है^२। गर्भजन्य विषमयता में आक्षेप आने के पहिले कभी-कभी स्त्री को द्विदृष्टि तथा आँखों के समक्ष चिन्तागिरियों की सी अनुभूति होती है जो विपरीतदृष्टिकोण संयोग से होता है, अतः इस विपरीतदृष्टिकोण संयोग को भी गर्भजन्य विषमयता में समाश्रित कर सकते हैं।

महर्षि कारश्यप ने गर्भिणी को नष्ट करने वाले अष्टि लक्षणों में संज्ञानाश्र होना अष्टि लक्षण माना है, जिसे गर्भजन्य विषमयता से उत्पन्न संज्ञानाश्र या मूर्छा भी ले सकते हैं^३। जातहारिणी के वर्णन में मोहिनी जातहारिणी के लक्षणों में भी गर्भजात्र या पातारि के साथ मूर्छा होना तथा क्रोशना में उदरस्थ गर्भ के कारण उदरवों का वर्णन है, जिसे भी गर्भजन्य विषमयता का अप्रत्यक्ष संदर्भ मान सकते हैं^४।

Mūrchā (unconsciousness) has been included under general signs of pregnancy, which is probably description of syncope state occurring due to transitory hypotension, not related to toxæmia of pregnancy. In the list of complications of obstructed labour, giddiness and abnormal perception of sense organs have been included, probably this refers to diplopia, scintillating scotomata etc. felt by woman suffering from toxæmia of pregnancy.

Kāśyapa has referred unconsciousness as a sign of bad prognosis and *mūrchā* as a symptom of *mohini jātaharīni*.

१. का० सं० चि० १०/११ से ११७ (पृष्ठ २७८, २७९)।
२. सु० सं० चि० ८६; अ० सं० शा० ४/३१ (देखें मूढगर्भान्तर्गत)
३. सु० सं० चि० ८६; अ० सं० शा० ४/३१ (देखें मूढगर्भान्तर्गत)
४. का० सं० चि० १०/१७०, १७१ (पृष्ठ २८९)
५. का० सं० ६ (अग्रिम पृष्ठों में वर्णित)

गर्भजन्य विषमयता में गर्भपात का निर्देश (Indication for abortion in toxæmia of pregnancy)

महर्षि सुश्रुत ने स्पष्ट लिखा है कि यदि विकार असह्य या असाध्य हो जाय तो गर्भपात करना श्रेयस्कर्म है। (कहाँ) गर्भिणी की स्थिति और न ब्याध जाय या मृत्यु न हो जाय, अतः प्रासकाल (चिकित्सा करने के लिए उपलब्ध थोड़े समय का) का उल्लेखन नहीं करना चाहिए^१। टीकाकार डल्हन ने शस्त्र, मन्त्र आदि चिकित्सा के असिद्ध होने पर गर्भिणी की रक्षा के लिए गर्भ के व्यावन का निर्देश देते हुए गर्भपात से गर्भिणी के जीवन की रक्षा का वर्णन दिया है^२।

शस्त्र एवं मन्त्र के बाद का 'आदि' शब्द औषधि-प्रयोग का द्योतक है। यद्यपि यह ज्ञातेक मूढगर्भ की गर्भाङ्ग छेदन चिकित्सा के बाद ही आया है, फिर भी इसका मूढगर्भ से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने गर्भपात शब्द का प्रयोग पाँचवें या छठे मास में पतित होने वाले गर्भ के लिए किया है। मूढगर्भता की स्थिति सातवें मास या उसके बाद होती है। टीकाकार डल्हन का शस्त्र-मन्त्र आदि स्पष्टीकरण भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि किसी भी स्थिति के गर्भ को निकालने की यही तीन विधियाँ हैं इन तीनों के असफल होने पर अन्य कोई विधि शेष ही नहीं रहती "प्रासकाल" शब्द के प्रयोग से ऐसा अभ्यास होता है, कि यह आततायिक व्याधि का, जिसमें चिकित्सा में तनिक भी विलम्ब से गर्भिणी-मृत्यु का भय हो, वर्णन है। व्याधि की गम्भीरता एवं निवारणार्थ गर्भपात का आदेश होने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह गर्भजन्य तीव्र विषमयता का वर्णन है।

Suśruta says that if the trouble is intolerable or incurable, abortion should be induced, lest the condition of woman deteriorates further or even she dies, the available short time should not be wasted.

Dalhana has explained this verse that in event of failure of treatment with *śāstra* (instruments) and *mantra* etc. the abortion should be induced to protect the life of pregnant woman. The word '*ādi*' i.e. etc. used after *mantra*, refers to use of drugs. This verse follows indications of destructive surgery for *mūḍha garbha* (obstructed labour), but does not appear to be related to it, because Suśruta has used term *garbhāpāta* for expulsion of fetus in fifth or sixth month, while obstruction in the process of labour occurs after this period i.e. seventh month onwards. Explanation of Dalhana i.e. failure with the treatment with instrument, *mantra* etc. (drugs) does not appear to be proper, because these are the only methods to terminate pregnancy of any duration. The emphasis on available short time indicates acuteness of disorder. Considering acuteness and seriousness of disorder and indication of abortion it may be considered as a description of toxæmia of pregnancy.

गर्भिणी को आक्रांत करने वाली रेवती या जातहारिणी (Revaṭi or jātaharīṇies afflicting a pregnant woman)

महर्षि कारश्यप ने अपनी संहिता के कल्पस्थान में एक रेवतीकल्प अध्याय का वर्णन किया है। यह रेवती स्त्री को विभिन्न अवस्थाओं (जःस्वला एवं गर्भावस्थादि) में आक्रान्त कर विकार उत्पन्न करती है। रेवती की उत्पत्ति का एक

१. अत्रिषु विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातम् । न गर्भिण्या विपर्यासस्तस्मात् प्रातः न हापयेत् ॥
(.....विपर्यास प्रासकालः..... - पा० भे० सी० के सेन कलकत्ता प्रकाशन) (सु० सं० चि० १५/११)
२. शस्त्रमन्त्रादितोषायेनासिद्धौ गर्भव्यावनं गर्भिणी रक्षार्थं कार्यमित्याह - अत्रिषु इति । सोऽनुमन्त्रस्ये विकारे व्याधौ सति किं कर्तव्यमित्याह - श्रेयो गर्भस्येति श्रेयो भवतीत्यर्थः । गर्भपातनफलमाह - न गर्भिण्या विपर्यास इति, विपर्यास मृत्युर्हित्यर्थः । तस्मात् प्रासकालं न हापयेन्नोऽङ्गुयेदित्यर्थः ॥ (सु० सं० चि० १५/११ की डल्हन टीका)

बहुत ही रोचक अध्ययन मिलता है। प्रजापति ने सर्वप्रथम काल को उत्पन्न किया। फिर देव, अमर, पिता, मनुष्य, सात ग्रामीण एवं वन्य पशु तथा अंगारियों एवं वनस्पतियों को रचना की तथा बाद में स्वेच्छा से शृंग को उत्पन्न की, जो क्षुधा प्रजापति में ही प्रकट हो गई। शृंग से प्रतिकार के लिए प्रजापति ने औषधि-सार का सेवन किया एवं शृंग से मुक्त हो गया। तब होकर प्रजापति ने शृंग का काल में आधान कर दिया। शुधित काल ने देवताओं एवं असुरों का पक्षण प्रारम्भ किया। देवताओं को ग्रथना पर प्रजापति ने अमृत का उपदेश किया एवं देवताओं ने उसका सेवन कर याल एवं शृंग दोनों को पराजित किया। पराजित होकर काल ने प्रजापति से इन भूतों को छीन लिया एवं असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दैर्घ्यजन्म नामक असुर कन्या ने देवताओं का संहर प्रारम्भ कर दिया। देवताओं की प्राथना पर कतिकेय ने रेवती को भेजा जिसने शालाग्रको^१ (स्फारी) का रूप धारण कर असुरों की सेना का संहर प्रारम्भ किया एवं सर्वप्रथम दैर्घ्यजन्म का ही भक्षण कर लिया तथा शकुनि का रूप धारण कर उल्का, विद्युत, पथरों एवं आगों की वर्षा करने वाली आदि अनेकों रूपों वाली वनकर असुरों को पराजित किया। संहर किए जाने हुए असुर मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के गर्भों में स्थित हो गए। रेवती ने उन्हें गर्भों में देख लिया एवं जातहारिणी वनकर उनका मंहार किया। यह अनेक रूपों वाली जातहारिणी रेवती, मिलिपिच्छिका, रैदी तथा वारणी आदि नामों से कही जाती है। यह स्कन्द की आज्ञा से सम्पूर्ण जातियों में उत्पन्न हुए अधार्मिक व्यक्तियों को मूढ़ कर देती है, दुष्टों का नाश करती है। मर्ग्य होने पर दिव्य चक्षुओं में ही दिखाई देती है तथा धर्म ही उसकी निवृत्ति का उपाय है^२।

Revati produces various abnormalities by afflicting the woman during her various stages i.e. menstruation, pregnancy etc. Kāśyapa has narrated a very interesting story regarding birth of *revati*. *Prajāpati* initially created *kāla* followed by *deva*, *asura*, father, human being, seven domestic and wild animals alongwith medicinal herbs and plants. After all this he created *ksudhā* (hunger) which entered in his own body. To get rid of this hunger he consumed essence of herbs and plants. After getting satiated, he transferred this hunger to the *kāla*. The hungry *kāla* started eating *devas* and *asuras*. Pleased with the prayers of *devas* and *asuras*, *prajāpati* preached them about *amṛta* (nectar). *Devas*, after using this nectar defeated both *ksudhā* and *kāla*. Defeated *kāla* snatched all above things from *prajāpati* and then *asuras* attacked *devas*. One *asura* daughter named *dirghajihvā* started killing *devas*. On the prayers of the *devas*, *kārikēya* sent *revati*. Who impersonating a she jackal first of all killed *dirghajihvā* and further started killing the army of *asuras*. Later on assuming the shape of vulture started showering meteor, thunder-bolt, stones and weapons. Getting defeated, these *asuras* entered the embryos of human and other animals. *Revati* assuming the name of *jātaharīṇī* killed these *vākāsas* there also. This *jātaharīṇī* is known by names of *revati*, *pilpichikā*, *raudhā* and *vāruṇī*. By the permission of *skanda*, she afflicts the impious or immoral persons of all the castes and kills villainous or unrighteous persons. She is seen by divine vision and religious virtues are the only remedies.

जातहारिणी के द्वारा आक्रमण (नाश) योग्य-स्थिति एवं काल (Appropriate condition and period for seizure by jātaharīṇī)

तस्माज्जातहारिणी पुष्पं हन्ति, वपुश्च हन्ति, गर्भाश्च हन्ति, जातंश्च हन्ति, जायमानांश्च जनिष्यमाणांश्च हन्ति। यद्धवत्सामुपगमिकणामपत्यमधर्मोदहतं विश्लेषण ॥ ७॥ (का० सं० क० ६)

१. शालाग्रक-वन्द, स्फार या कुता (अमरकोष); भेड़िया, बिछा, कुता, स्फार (मो० वि०); हिरण एवं वन्दर भी (आदि)

२. का० सं० कल्पस्थान ६/१ से ७॥ (का० सं० के पृष्ठ ३५१ से ३५३)

रजस्वला गर्भिणी वा प्रसूता वा कुटीगताम्।
स्त्रियमविशते क्लृप्ता त्रिषु कालेषु रेवती ॥ ६५॥ (का० सं० क० ६)

वह जातहारिणी पुष्प (आतक) का नाश करती है, वपु (शरीर या यहाँ शरीरपिण्ड), गर्भ, उत्पन्न हो गए, उत्पन्न होते हुए तथा उत्पन्न किए जाने वाले प्राणी को नष्ट करती है। विशेष रूप से असुरों एवं अधार्मिक व्यक्तियों के पुत्रों तथा अधर्म युक्त प्राणियों को नष्ट करती है।

क्लृष्ट हुई रेवती तीनों कालों में (आयु के तीनों काल यथा बाला, मध्यमा एवं वृद्धावस्था तथा दिन एवं रात के तीनों काल यथा प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त), रजस्वला, गर्भिणी, प्रसूता तथा कुटी में स्थित (कुटीप्रावेशिक रसायन प्रयोग करने वाली या अन्तर्गृह में बैठी हुई) स्त्रियों में प्रवेश करती है।

Jātaharīṇī causes disappearance of *puspa* (menstruation), destructs body, fetus, born/ getting birth/ to be born creatures specially *asuras*, non religious persons or their children. *Angry revati* afflicts a menstruating, pregnant, puerperal or *kuṭigata* (staying inside a hut) woman during all the three periods (childhood, middle age and old age and also in beginning, mid and end of the day and night).

जातहारिणी के भेद (Classification)

जातहारिणी के साध्यासाध्या एवं संक्रमण की दृष्टि से भेद किए गए हैं।

(१) साध्यासाध्या की दृष्टि से भेद:-

शाक्यतस्त्रिविधमाहुर्मुनयो जातहारिणीम् ॥ ६०॥

साध्यां याप्यामसाध्यां च (का० सं० क० ६)

शाक्यों के अनुसार मुनियों ने तीन प्रकार की जातहारिणी कही है साध्या, याप्य एवं असाध्या।

(२) संक्रमण की दृष्टि से भेद:-

अथ खलु वृद्धजीवक ! त्रिविधैव जातहारिणी प्रोच्यते लोकभेदाः-दैवी, मानुषी, तिरश्चीनेति ॥ ६२॥

(मानुषी भेद) अथ खलु वृद्धजीवक ! इमाः स्त्रियश्चतुर्विधा जातहारिण्याविश्य स्त्रियमत्र प्रविशति।

वर्णाः वर्णान्तरां लिङ्गिनीं कारुकीमिति । ॥ ६८॥

अत ऊर्ध्वं वृद्धजीवक ! तिरश्चीं जातहारिणीमनुब्याख्यास्यामः-पञ्चविधा ह्येषा प्रोच्यते। तद्यथा-शकुनी, चतुष्पदी, सर्पा, मत्सी, वनस्पतीरिति ॥ ६९॥ (का० सं० क० ६)

हे वृद्धजीवक ! लोकभेद के अनुसार तीन प्रकार की जातहारिणी कही जाती है, दैवी, मानुषी एवं तिरश्चीन। मानुषी में वर्णा, वर्णान्तरा, लिङ्गिनी तथा कारुकी नामक चार प्रकार की जातहारिणी प्रवेश करके अन्य स्त्रियों में प्रविष्ट होती है।

तिरश्चीन जातहारिणीयाँ पाँच प्रकार की कही गई हैं:-शकुनी, चतुष्पदी, सर्पा, मत्सी एवं वनस्पती।

It is classified in two ways:

- A) On the basis of prognosis: (i) *Sādhyā* (curable), (ii) *Yāpyā* (easily relapsable), (iii) *Asādhyā* (incurable).

If husband also practices similar acts, the *jātāhārīnī* becomes incurable. If only one partner is unorthodox, the *jātāhārīnī* is difficult to be cured, however, if both the partners are orthodox, honest and free from pride and diseases, the progeny progresses.

If a woman during her first pregnancy maintains close contact with her friend who has lost her progeny or other woman who is impure or dirty, inauspicious, unchaste, divorcee or afflicted with *jātāhārīnī*; cuts, bathes and exchanges garments and ornaments with them; attacks their bathing, unination or sacrificial places; specifically attacks their scalp and body hair, nails, ungents, old cloths and cuttings (cut nails, hair etc.), (cloth) soaked with menstrual blood, uses their left-over food, medicines, perfumes and flowers and wears their old shoes, then *jātāhārīnī* afflicts her.

When a woman during her first pregnancy has beautiful body, is healthy, has corpulent hips, breasts, thighs along with arms and good looking face; possesses good luck, beautiful hair, big eyes with redness in inner corners and increasing *romarvī* (linea nigra); has unctuous or glistening palm, foot, nails, vision and skin; is delicate, can not withstand troubles or pain, can not work hard; whose fetus is progressing well with time, body is developing properly, the milk secretion is being formed, then the wicked persons have spite or see her with evil eye. If precautionary measures are not adopted then the *jātāhārīnī* afflicts the pregnant woman.

Due to this very reason daily performance of *putryakāmesī yajña* has been advised, this wipes the effect of sins. The pregnant woman should not eat even with her own mother, specially negligence should not be done during the first pregnancy.

(२) पुरुष के या अन्य अपचार से (Due to misdeeds of husband and other causes)

बहुभार्यस्य विप्रस्य संप्रसक्तस्य याजने ॥ ११॥

विदुषोऽपि स्वदोषेण सज्जते जातहारिणी । आक्षेपा यश्च वादेषु दाभिषकोऽहङ्कृतश्च यः ॥ १०॥ सर्वं ते जातहारिण्या भक्ष्यभूताः सयाजकाः । रात्रौ यदा गतो मागात् पतिः पासुलपादकः ॥ ११॥ स्मर्येद्वती वा गर्भे वा तदाऽऽविशति रेवति । गृहीतां जातहारिण्या सेवित्वा यः स्त्रियं पतिः ॥ १२॥ भार्याभूयति तत्कालं सज्जते जातहारिणी । गृहीतं जातहारिण्या गृहं नित्यं च वर्जयेत् ॥ १३॥ आदत्तानं ततः किञ्चिद्गृहीते जातहारिणी । वद्यभेदाङ्गकर्णौर्गवां बन्धनदेहिनेः ॥ १४॥ गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमता जातहारिणी । महिष्युष्यजपालानामेवमेव प्रजाक्षयम् ॥ १५॥ करोत्यधर्मसंजाला प्रसक्ता जातहारिणी । ब्रह्मस्वहारिणो लोके विषमाणां दुःखानाम् ॥ १६॥ तत्कारणां शत्रूनां च प्रजा हन्त्युपरेवती । रसनाः पापकायाणां दुष्कृता भिन्नसेतवः ॥ १७॥ ये भवन्त्ययग्रया निर्दयाः सर्वजातिषु । अस्तिष्णस्तीष्णदण्डा वृद्धानां शासनानिमाः ॥ १८॥ अन्योक्षितवृत्तान्ता अधर्मस्य प्रवर्तकाः । राज्ञो यस्य च दौर्बल्यात् क्षयं यन्तीह च प्रजाः ॥ १९॥ गोब्राह्मणं विशेषेण हन्ति तं जातहारिणी । एवमेव दुरात्मनो राजमात्रा गुणज्ञया ॥ २०॥ प्रजा यदा प्रबाधन्ते हन्ति तज्जातहारिणी । वणिक् पयसोपगती यो यशस्यस्य प्रतीक्षकः ॥ २१॥ अतिवार्युषिकश्चैव हन्यन्ते बहुरूपाः । कन्याया यश्च भूयेश हिण्यस्यशवासमम् ॥ २२॥ कुर्वन्ति येऽनुताप्येभ्यो (धातिनी) जातहारिणी । सम्यगोरपु रजसि शून्यदेवालयेषु च ॥ २३॥ मैथुनं यान्ति ये मोहाद्धन्ति तज्जातहारिणी । ॥ २४॥

न चाधर्मभूते नर्तौ विप्रते जातहारिणी । मातुः पितुः सुतानां च साऽधर्मेण प्रवर्तते ॥ ६६॥
..... मातृणां च प्रजाक्षयम् । आयुः क्षयं च बालानां कोट्येषा स्वकर्मजम् ॥ ६७॥
(क० सं० क० ६)

बहुत यत्र किए हुए एवं बहुत यत्र करने में व्यस्त विद्वान् व्यक्ति को भी जातहारिणी स्वदोष से ही आक्रान्त करती है । विद्वान् में बहुत आक्षेप करने वाला, दम्भी, अहंकारी तथा याजक सभी जातहारिणी द्वारा भक्ष्य होते हैं ।

रात्रि में मार्ग से चलकर आया हुआ पति पैरों में धूल लगे हुए ही अथवा ऋतुकाल या गर्भावस्था में यदि स्त्री को स्पर्श करता है तो स्त्री को जातहारिणी प्रवेश कर जाती है ।

जातहारिणी से आक्रान्त (अन्य) स्त्री का सेवन करके पति जब तत्काल ही पत्नी के पास जाता है तो उसे जातहारिणी आक्रान्त कर देती है ।

जातहारिणी से आक्रान्त घर का सदा त्याग कर देना चाहिए, उस घर में से कुछ भी लेने वाले व्यक्ति को जातहारिणी आक्रान्त कर देती है ।

गौओं के बाध, अंगमेद, वधम तथा दोहन इत्यादि कारणों से गोमता जातहारिणी गवाले (गौओं को पालन करने वाले) की सन्तान का हनन कर देती है । इसी प्रकार अधर्म से उत्पन्न जातहारिणी महिषी, उष्ट्री एवं अजा का पालन करने वाले व्यक्तियों की भी सन्तान को नष्ट कर देती है ।

उग्र रेवती (अति उग्र स्वरूप वाली रेवती) लोक में ब्रह्मस्व (ज्ञान) का हणन करने वाले, विषम, दुरात्मा, तस्कर तथा शठ लोगों की सन्तान को नष्ट कर देती है ।

पाप कार्यों में रात, नीच कुल वाले, मर्दाद का उल्लंघन करने वाले, अन्याय करने वाले, सभी जातियों के प्रति निर्दयी, अरक्ष या रक्षा से विवर्धित, तीक्ष्ण दण्ड धारण करने वाले, वृद्धों के शासन को न मानने वाले व्यक्तियों को अथवा अन्योक्षित वृत्तान्त करने वाले, अधर्म के प्रवर्तक व्यक्ति तथा उस राजा को जिसकी दुर्बलता के कारण प्रजा विशेष कर गौ एवं ब्राह्मण का क्षय हो, जातहारिणी नष्ट कर देती है ।

इसी प्रकार जब दुरात्मा व्यक्ति, उसी प्रकार (दुरात्मा) के राजा की आज्ञा से प्रजा को कष्ट पहुँचाते हैं, तो उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ।

जो वणिक् बाजार का व्यतिक्रम करता है अथवा इसी का अनुगामी है, तथा जो धन की वृद्धि का इच्छुक है, वह अनेक रूपों वाली जातहारिणी द्वारा विनष्ट हो जाता है ।

कन्या, भूमि, स्वर्ण, अश्व तथा वस्त्रों के विषय में जो (व्यक्ति) अनृत (असत्य) व्यवहार करते हैं, उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ।

जो व्यक्ति अज्ञानवश दोनों सभ्यार्थों में, जल में (जल स्थान अर्थात् नदी या तालाब में), धूल में एवं शून्य देवाल्यों में मैथुन करते हैं उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ।

यह जातहारिणी माता, पिता अथवा पुत्र के अधर्म के बिना नहीं प्रवेश करती । अपने कर्मों के कारण माताओं की प्रजा का तथा बालकों की आयु का क्षय करती है ।

An erudite who had performed several *yajñas* and is still busy in *yajñas* is attacked by *jātāhārīnī* due to his own mistakes. All the persons who either interrupt too much in discussions or are hypocrite, egoistic and sacrificer are vulnerable for attack by *jātāhārīnī*.

If a husband having walked on a path and having his feet covered with dust touches his wife or else touches (has sexual relation) her during menstruation or pregnancy, the

jātahārīṇī attacks the woman.

When a man goes to his wife immediately after having copulation with a woman seized with *jātahārīṇī*, the *jātahārīṇī* attacks her (his wife).

A house afflicted with *jātahārīṇī* should always be abandoned. *Jātahārīṇī* attacks the persons taking any thing from that house.

Due to killing, injuring the body parts, tethering and milking done by cow-herd the *gomāṭā jātahārīṇī* kills his progeny. Similarly *jātahārīṇī* born due to unrighteousness kills the progeny of keepers of she bullock, camel and goat.

Virulent *revatī* destroys the progeny of those who carry the knowledge (of god) from society, are abnormal, evil natured, thief and rogue.

Jātahārīṇī kills those who are busy in sinful acts, born in low caste, cross the limitations of normal laws, do injustice, are cruel to every caste, are unprotected, carry sharp edged sticks, do not obey elders, narrate unwanted events, propagate unrighteousness and also kills that king whose weakness causes decadence to public specially decline of cows and *brāhmaṇas*.

Similarly when evil natured person, obeying the orders of similar type of king trouble the public, the *jātahārīṇī* destroys them.

When a merchant transgresses the market or follows the same path and is desirous of accumulating wealth, then he is destroyed by *jātahārīṇī* of various shapes.

The person who does fraud or false behaviour about maiden, land, gold, horses and cloths is killed by *jātahārīṇī*.

The persons doing coitus due to ignorance during both twilight, in water (ponds, lakes or rivers etc.), dust and lonely temples are killed by *jātahārīṇī*.

The *jātahārīṇī* does not enter without unrighteousness of mother, father or son. Due to one's own deeds it finishes the progeny of mothers and longevity of children.

दैवी आदि विशिष्ट जातहारिणी वर्णन (Description of daivy etc. specific jātahārīṇī)

(१) दैवी जातहारिणी (Daivy i.e. divine jātahārīṇī)

तस्मात्तयो लोका भगवत्या रेवत्या बहुरूपया व्याप्ताः । इत्यतश्च सर्वलोकभयङ्करी रेवती पठ्यते । तां देवा अम)न्यन्त, तत एषां प्रजाः प्रावृष्यन्त; न एषां प्रजा विच्छेदमगमत् । नास्य प्रजा विच्छेद्यते य एवं वेद । तामय रेवतीं सर्वलोकानुगमिष्यपिकां सर्वशीणां कश्यप एवाग्रे तपस्येष्टोपाविन्त । तस्मै प्रजां बहुलामशीरायुभृतीमविच्छिन्नां प्रादात् । ततः सर्वेष्टोऽभ्यधिकोऽभवत् । रेवतीमेकशोऽभिज्ञश्च रेवतीकल्पं शिष्येष्व्यः प्रादाज्जागृह्णताम् ॥ ६२ ॥

अतो वृद्धजीवक ! निकका दैवी रेवती ॥ ६३ ॥ (का० सं० क० ६)

इस प्रकार तीनों लोक भगवती रेवती के अनेकों रूपों से व्याप्त हैं । इसीलिए सर्वलोकों में रेवती भयंकर कही जाती है । इस रेवती का देवता सम्मान करते हैं जिससे उनकी सन्तानों की वृद्धि होती है, उनकी सन्तानों का विच्छेद (नाश) नहीं होता, ऐसा विदित है । सभी लोकों की गुरु तथा सर्वत्र व्यापक इस रेवती को सभी ऋषियों से पूर्व महर्षि कश्यप ने उग्र तपस्या के द्वारा ज्ञात किया था । जिसके आशीर्वाद ने (कश्यप को) बहुत सी आयुष्मान, अविच्छिन्न (नाश रहित)

सन्तान प्रदान की । इससे उनके सब से अधिक सन्तानें हो गई । रेवती को एकात्मरूप (पूर्णरूप) से जानकर महर्षि कश्यप ने लोक-कल्याण के लिए शिष्यों को रेवतीकल्प का ज्ञान प्रदान किया । हे वृद्धजीवक ! दैवी रेवती का वर्णन कर दिया ।

This *revatī* is present in all the three places (heaven, hell and earth) in various shapes, that is why it is called very ferocious. Because the deities respect the *revatī*, so their progeny increases, their children do not die. Kaśyapa acquired knowledge of this universal preceptor and omnipresent *revatī* by his intense penance, and obtained good number of healthy children having longevity due to her blessings, he got maximum children. Kaśyapa after acquiring complete knowledge about *revatī* preached it to his disciples for the benefit of the universe. *Vridhhaṭvaka* : this is the description of daivy (divine) *jātahārīṇī*.

(२) वर्णा, वर्णान्ता, लिङ्गिनी एवं कारकी आदि मानुषी जातहारिणियों की प्रवेश विधि एवं निराकरण उपाय (Methods of entry and remedy of varṇā, varṇāntarā, liṅgiṇī and kārākī etc. mānuṣī i.e. human jātahārīṇī)

मानुषीमत्र व्याख्यास्यामः—तत्र यथोक्तैर्यमर्द्धैर्यां चित्रियमत्र प्रविशति, तां तां त्रियमनुवर्तयिष्यामः ॥ ६३ ॥

ताः खल्वतो व्याख्यास्यामः । अथो वृद्धजीवक ! ब्राह्मणों समाविष्टां गृहानागतं स्त्रीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संवदति संसृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशते पदमुत्तिर्नामत्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी भवति । अथो आहुः—सैवैनां ब्राह्मणी ऋतुमतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावर्ती करोति । नास्या ब्राह्मणी जातहारिणी भवति, या एवं वेद ।

अथो वृद्धजीवक ! क्षत्रियां जातहारिणीं समाविष्टां गृहानागतं त्रियं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संवदति संवदति संसृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशते पदमुत्तिर्नामत्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्याः क्षत्रिया जातहारिणी भवति । अथो आहुः—सैवैनां क्षत्रिया ऋतुमतीमवसिञ्चेत्, सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावर्ती करोति । नास्याः क्षत्रिया जातहारिणी भवति, या एवं वेद ॥

अथो वृद्धजीवक ! वैश्यं जातहारियाऽविष्टामथो महाशूद्रां स्त्रीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संवदति संसृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशते पदमुत्तिर्नामत्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या वैश्य जातहारिणी भवति, अथो शूद्रा, अथो महाशूद्रा वा । अथो आहुः—सैवैनां वैश्याऽथो शूद्राऽथो महाशूद्रा त्रियमुत्तुतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावर्ती करोति । नास्या वैश्या वा शूद्रा वा महाशूद्रा वा जातहारिणी भवति, या एवं वेद ।

अथो वृद्धजीवक ! स्तनमागधेयमुष्णमावृष्टप्राच्यकचपाडालमुष्टिकमेत(द)डौबडवाकटुमिडरिहलोडूख-शशकचनपल्लवतुण्ड(वा)कम्बोजावन्यनेमकाभीरकहणपाशवकुलिनदीकितशवश्याम्बराजा जातहारिण्यो भवन्ति । अथो आहुः—तामेवैनां(ना)स्तिकनिषादप्रभृतीनां वर्णमङ्कणाणां वा या त्रियो जातहारिण्योऽविष्टा गृहानीयुस्तः स्त्रीः प्रत्युपतिष्ठते, अभिवादयते, अभिनन्दयते, संवदति, संसृशति, संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशति, उपशते पदमुत्तिर्नामत्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्याः एता वर्णमङ्कराजा जातहारिण्यो भवन्ति । अथो आहुः—तामेवैनां त्रियमुत्तुतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावर्ती करोति । नास्या वर्णमङ्करा जातहारिणी स्त्री जातहारिणी भवति, या एवं वेद ।

अथो वृद्धजीवक ! लिङ्गिनी परिव्राजिका श्रमणका कण्डनी निर्गन्धी वीरवल्कलधारीणी तापसी चरिका जटिनी मातृमाडलिकी देवपरीवारिका देशिका वा जातहारिण्यो वा जातहारिण्याऽविष्टा वा गृहानुपेयात् तां प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते वा संवदति वा संसृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशते पदमुत्तिर्नामत्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या लिङ्गिनी जातहारिणी भवति । अथो आहुः—सैवैनां लिङ्गिनी त्रियमुत्तुतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र

प्रायश्चित्तः । स्वेनैवंनां भगधेयेन प्रजावर्त्तं करोति । नास्या त्तिङ्गिनी जातहारिणी भवति, या एवं वेद ।

अथो वृद्धजीवक ! असकरी जातहारिण्याऽऽविष्टा काष्ण्यायसेनार्हाणोनाश्वेत्यथो तक्षणी दारवेणथो कुलाली मतिकेनाथो पदकरी चामोणोनाथो मालाकरी मुक्तकुसुमेनाथो कुविन्दी तानुकेनाथो सौचिकी स्यूतेनाथो रजकी सुतेनाथो नेजका निर्गिन्नेनाथो गोपी तक्षेणथो कारकुणीकी प्रवेनार्हाणेन जातहारिण्याविष्टा गृहगुपेयात् तां स्त्रीं प्रत्युपनिष्ठोऽभिवादयते संवदति संस्पृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याकोशोत्पुष्यते पदभृत्निर्माल्यवासोलङ्का-रमाकामति वा तस्याः कारकुणीकी जातहारिणी भवति । अथो आहुः--स्वेनैवं कारकी स्त्रियापुमृतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तः । स्वेनैवंनां भगधेयेन प्रजावर्त्तं करोति । नास्याः कारकी जातहारिणी भवति, या एवं वेद ॥ ६८॥ (का० सं० का० ६)

यथोक्त अधर्म रूपां द्वारों अर्थात् अधर्म के कारण जिन स्त्रियों में वह जातहारिणी प्रवेश करती है, उन उन को व्याख्या करेंगा ।

हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री (अपने) घर में आई हुई ब्राह्मणी जातहारिणी से समाविष्ट स्त्री के पास बैठती है, उसे अभिवादन करती है, (उसके साथ) व्यवहार करती है, बातचीत करती है, (उसे) स्पर्श करती है, (उसके साथ) खाली है, (उसे) मारती है, गाली देती है, (उसके साथ) सोती है, या उसके पैर, श्मश्रु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है, उसे ब्राह्मणी जातहारिणी हो जाती है (प्रविष्ट हो जाती है) । कहा गया है कि वही (ब्राह्मणी जातहारिणी से पहिले से ही आक्रान्त) ब्राह्मणी इस श्मश्रुमती (बाद में आक्रान्त स्त्री को श्मश्रुमती के समान) स्त्री का अवसिंचन करे, यही इसका प्रायश्चित्त है । वह अपने भगधेय (अंश) से उसे संतानयुक्त करती है । जो इस तत्त्व को जानती है उसे ब्राह्मणी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती ।

हे वृद्धजीवक ! क्षत्रिया जातहारिणी से आक्रान्त घर में आई हुई स्त्री के पास (जो स्त्री) बैठती है, (उसका) अभिवादन करती है, (उसके साथ) व्यवहार करती है, बातचीत करती है, (उसे) स्पर्श करती है, (उसके साथ) भोजन करती है, (उसे) मारती है, गाली देती है, उसके साथ सोती है, उसके पैर, श्मश्रु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है, उस (इन सभी कर्मों को करने वाली स्त्री) को क्षत्रिया जातहारिणी हो जाती है । कहा गया है कि वह क्षत्रिया (जातहारिणी आक्रान्त स्त्री) इस श्मश्रुमती का अवसिंचन करे, यही इसका प्रायश्चित्त है । वह (क्षत्रियाविष्ट स्त्री) अपने ही भगधेय से इसे (बाद की आक्रान्त स्त्री को) संतान युक्त करती है । जो इस तत्त्व को जानती है, उसे क्षत्रिया जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती ।

हे वृद्धजीवक ! जो (स्त्री) वैश्य अथवा महाशूद्री जातहारिणी से आविष्ट स्त्री के पास बैठती है, उसका अभिवादन करती है, उसके साथ व्यवहार करती है, उससे बातचीत करती है, उसे स्पर्श करती है, उसके साथ भोजन करती है, उसे मारती है, गाली देती है, उसके साथ सोती है, उसके पैर, श्मश्रु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों को आक्रमण करती है, उसे यह वैश्य, शूद्री या महाशूद्री जातहारिणी हो जाती है, कहा गया है कि वह वैश्य, शूद्री अथवा महाशूद्री स्त्री श्मश्रुमती का अवसिंचन करे । यही इसका प्रायश्चित्त है । वह अपने ही भगधेय से इसे प्रजावती करती है । जो यह जानती है, उसे वैश्य, शूद्री अथवा महाशूद्री जातहारिणी नहीं होती ।

हे वृद्धजीवक ! (इनके अतिरिक्त) सूत, मायाध, वेन, पुक्रस, अम्वष्ठ, प्राच्यक, चण्डाल, मुष्टिक, मेत(र)डौम्प, डावक, दुमिड, सिंहल, उड्ड, खण्ड, शक, यवन, पल्लव, गुड्डा(ष)र, कम्बोज, अवन्ती, अनेमक, अभीरक, हूण, पाराश, वकुलितन्द, किरात, शबर तथा शम्बर आदि देशों में उत्पन्न होने वाली जातहारिणियाँ होती हैं । जो स्त्रियाँ इन नास्तिक, निषाद आदि वर्णशंकर जातहारिणियों से आविष्ट स्त्रियों के पास बैठती हैं, (उनका) अभिवादन एवं अभिनन्दन करती है, (उन्से) व्यवहार करती है, (उन्से) बातचीत करती है, (उन्हें) स्पर्श करती है, उनके साथ भोजन करती है, उन्हें मारती एवं गाली देती है, उनके साथ सोती है, उनके पैर, श्मश्रु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों को आक्रमण करती है, उन्हें वे वर्णशंकर जातहारिणियाँ

आक्रान्त कर देती हैं, कहा गया है कि वे (जातहारिणी आविष्ट स्त्रियाँ) श्मश्रुमती का अवसिंचन करें, यही इसका प्रायश्चित्त है । (वे) अपने ही भगधेय से इसे प्रजायुक्त करती हैं, जो इस तत्त्व को जानती है, उसे वर्णशंकर जातहारिणियाँ आक्रान्त नहीं करती ।

हे वृद्धजीवक ! लिङ्गिनी, परित्राजिका, श्रमणका, कण्डनी, निर्गन्धी, चौवलकलधरणी, तापसी, चरिका, जटनी, मातृमण्डलिका, टेम्पविकारिका एवं वैश्वणिका आदि जातहारिणियाँ या उनसे आविष्ट स्त्री जब घर में आती है, तब जो स्त्री इनके पास बैठती है, इनका अभिवादन एवं इनसे व्यवहार करती है, इन्हें स्पर्श करती है, साथ में भोजन करती है, इन्हें मारती एवं गाली देती है, साथ में सोती है, पैर, श्मश्रु, माला, वस्त्र तथा अभूषणों पर आक्रमण करती है, उसे लिङ्गिनी जातहारिणी हो जाती है । कहा गया है कि यह लिङ्गिनी (आविष्ट) -स्त्री श्मश्रुमती का अवसिंचन करे, यही इसका प्रायश्चित्त है । वे अपने ही भगधेय से इसे संतानयुक्त करती हैं । जो इस तत्त्व को जानती है उसे लिङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती ।

हे वृद्धजीवक ! जब अयस्करी जातहारिणी से आविष्ट स्त्री कृष्ण लोह के बने, तक्षणी (बहुइन) दाग (लकड़ी के बने शस्त्र) के, कुलाली (कुम्हारिन) मिट्टी के, पदकरी (चमारिन) चमड़े के, मालाकरी (मारिन) मुक्त कुसुम (खिले हुए फूलों) के, कुविन्दों तानुक के, सौचिकी (दर्जी) स्यूत के, रंजकी (रंगने वाली) भलीभाँति रंजित वस्त्रों के, नेजका (शोचिन) निर्गन्ध के तथा गोपी (गवतिन) तक्र के, आदि अपनी-अपनी वस्तुओं से निर्मित उपहारों के सहित कारकुणी(की) जातहारिणी से आविष्ट (हुई स्त्रियाँ) घर में प्रवेश करती हैं, तो जो स्त्री इनके पास बैठती है, इनका अभिवादन करती है, इससे व्यवहार करती है, बातचीत करती है, स्पर्श करती है, साथ में भोजन करती है, उन्हें मारती है, गाली देती है, उनके साथ सोती है, उनके पैर, श्मश्रु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों को आक्रमण करती है । उसे कारकुणी(की) जातहारिणी हो जाती है । कहा जाता है ये कारकी (जातहारिणी आविष्ट स्त्री) श्मश्रुमती का अवसिंचन करे, यही इसका प्रायश्चित्त है । वे अपने ही भगधेय से इसे सन्तानयुक्त करती हैं । जो यह तत्त्व जानती है उसे कारकी जातहारिणी नहीं होती ।

A woman gets afflicted with *brāhmanī jātahāriṇī* who closely sits with other woman entered into her house and afflicted with *brāhmanī jātahāriṇī*, salutes her, does dealings and talks with her; touches, hits and abuses her, eats and sleeps with her; attacks her feet, pads used during menstruation, girdland, garments and ornaments. It is said that the same *brāhmanī* (woman already afflicted with *jātahāriṇī*) should bedew this *rūmanī* (subsequently afflicted woman during menstruation), this is the only expiation. She (the former) provides her (the later) progeny with her own share or destiny. Who knows this secret never gets attacked by *brāhmanī jātahāriṇī*.

The description of other *varṇā jātahāriṇīs* i.e. *kṣatriyā, vaiśyā, śūdrī* or *mahāśūdrī; vāṇijikā jātahāriṇīs* or other than above castes such as born in *sūta, māgadhā, vena, pukkasa, ambasīḥa, prācyaka, candāla, musjika, medadāmba, dāwēka, dhumāda, sīṇhala, udra, khaśa, yavama, pallava, usāra, kamboja, avanī, anemaka, tōhīraka, hūṇa, pārāśa, vakulinda, kirāṇa, śābava* or *śāmbava* etc. castes or countries and other atheist *nijāda* etc. crossbreeds; and *liṅgiṇī jātahāriṇīs* i.e. *liṅgiṇī, parivṛjīkā, śramāṇakā, kaṇḍānī, nīrgandhī, cīravalkaladhāriṇī, tapasī, carikā, jātānī, māṛmanādālikā, devapariṇārikā* and *veksanīkā* etc. is identical to the description of *brāhmanī jātahāriṇī* except the substitution of word *brāhmanī* with specific castes.

The description of *kāruki jātahāriṇī* is also the same, however the woman belonging

to specific profession already afflicted with *jātaharīṇī* enters the house of other woman with presents prepared according to their profession as follows:—

Woman of profession	presents made of
<i>Ayaskari</i> (blacksmith)	Black iron
<i>Takṣmī</i> (carpenter)	Weapons of wood
<i>Kulātī</i> (potter)	Clay
<i>Padakari</i> (shoemaker)	Leather
<i>Mālākari</i> (gardener)	Blossomed flowers
<i>Karvīnī</i> (weaver)	Specific yarn
<i>Sauvīkī</i> (tailor)	Cotton thread
<i>Ramjīkī</i> (dyer)	Coloured garments
<i>Nejīkī</i> (washer-woman)	Cleansed cloths
<i>Gopī</i> (milk-woman)	Buttermilk

(३) शकुनी, चतुष्पदी, सर्प, मत्सी एवं वनस्पति आदि तिश्चीन जातहारिणीयों की प्रवेश-विधि, लक्षण एवं निराकरण उपाय (*Process of entry and remedy of śakunī, catuṣpadi, सर्प, mātī and vanaspati etc. bhāṣṭina jātaharīṇīs.*)

अत ऊर्ध्वं वृद्धजीवक ! तिश्चीं जातहारिणीमनुयाह्यास्यामः^(१) ता एता प्रायेण सतामेव प्रसज्जन्ते ।

वृद्धजीवक ! ये शकुनीं वृद्धन्तीं ज्वन्ति घातयन्ति वा तेषां शकुनिरूप जातहारिणी प्रसज्जन्ते महाग्रहः । सा काकी भामसी कुक्कुटी मयूरी चाषी सारिका तैलपायिका, उलूकी, भोलान्तिका, गृथी, रयेनी, भारद्वाजो ततोऽन्यतमा वा भूत्वा स्वर्नपूर्वात् दर्शयति, गर्भिणीं सूतिकां विभीषयति, बालं चोन्नतयति, महानेगा महाप्राणा घोररूपः रौद्राणायातक्षा वज्रतुण्डनवदशनदंष्ट्रा वैदूयन्तलनसदृशलोचना बहुविचित्रमहापञ्चा कण्ठे कनकमणिविचित्रपुण्ड्रधारिणी विविधकुसुमगन्धवनमुसलोज्ज्वलधारिणी वरमुकुटा नपुकाविकनकदङ्गाटकादकुण्डलवामघण्टाधराकालाऽऽतपत्रोलकाविद्युन्मेषमालाऽलङ्कृता, भगवतः कुमारावरस्य ग्रानी (?) च स्वसा च स्वने धर्माधिया योगागमनन्तरमस्य करोति । ततो मध्याह्नेऽधरात्रे वा संध्योर्वा सुप्ते वा बालगृहे निलीयते यथोक्तानामेकतमा; ततो बाल उच्चैः क्रोशति, रोदति त्रसते वेपथे विभोति ज्वर्यते विह्वलति निस्तनति मुह्यति विस्वहलति सूच्यते शून्यते विस्त्रस्यते रोगैरन्यैश्चेत्पश्यते । या त्वभीक्ष्णं शकुनीं स्त्री स्वने पश्यति ततः साऽस्याः शकुनी जातहारिणी सज्जते । तस्या एव शकुन्या निर्भातस्या (निलीनाया ?) एव पुरीषेण पक्षोदकेन दैनां वृद्धस्त्री शकुनिनामीं स्त्रीं तत्रावाप्तमञ्जेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैतन् भागधेयेन प्रजावर्ती सिद्धं करोति । नास्याः शकुनी जातहारिणी भवति या शकुनी न हिनस्ति, या एवं वेद ।

अथो वृद्धजीवक ! ये गां ज्वन्ति घातयन्ति वा, गौमांसं चोपयुञ्जन्ते तेषां गोमता जातहारिणी प्रसज्जन्ते । एषा एतां स्वर्नोऽभिभवति गोपालो वा वसत्कपालो वा, असाध्य तस्या गोमता जातहारिणी प्रसज्जति । अथो आहुगोमध्व एतां गोमृदुरीषाभ्यामुपोषितां स्पृशेत्, सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैतन् भागधेयेन गोः प्रजावर्ती करोति । नास्या गोमता जातहारिणी भवति, या गां न हिनस्ति, या एवं वेद । एवमेव महिषीणामजानामविकानां गार्दभीनां श्वश्वतरीणामुशीनां सूकरिणां शूनीनां गलगोलिकानां गोपानां (गोधानां ?) विश्वभराणां मृगादीनां चैवमेव विधिरक्तः ॥

१. गोप या गोप का शाब्दिक अर्थ गोपालक या गोरक्षक होता है, बौद्ध ग्रह वर्णन चतुष्पदी जातहारिणीयों का है अतः गोरक्षक शब्द युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । गोषा एक चतुष्पाद जीव है एवं ग्रह सम्भव है कि मृदुण या टंकड़ शृट से गोषा शब्द के स्थान में 'गोप' शब्द आ गया हो ।

अथो वृद्धजीवक ! सर्प गृहघ्राणिगृहघराणां वा स्त्री हस्ति घातयन्ति वा, तस्याः सर्प जातहारिणी प्रसज्जन्तेऽथो विषमृगमस्याः प्रजाया आहः । एतां वल्मीके नागकुले वा सिञ्चेदथो आहुर्वल्मीकशतमस्य इति । मंत्र तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैतन् भागधेयेन प्रजावर्ती करोति, नास्याः सर्प जातहारिणी भवति । या सर्पात् न हिनस्ति, नास्याः प्रजाया विषमृगमृगवति या एवं वेद ॥

अथो वृद्धजीवक ! या मत्स्यमकरातिमिङ्गलनकशङ्खशाम्बकसुखनकादीनि भूतान्युदकघराणि हन्ति, तस्याग्ने-नाधर्मेण रेवती कुब्जा प्रजा हिनस्ति, मत्सी वा मकरी शुक्तिः शङ्खी भूत्वा स्वने पूर्वं हृषयति, ततो हिनस्ति भृगुधः तस्या अप्सु प्रजा विनश्यति, जलरासेन एकैकरोषोर्वा । अथो आहुः—रोहिणीन्तानैवैतान् प्रत्युदियात्, सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । या मत्स्यान् न हिनस्ति नास्या मत्सी जातहारिणी भवति, या एवं वेद ।

अथो वृद्धजीवक ! ये वनस्पतीन् हिसन्ति परिगृहीतानपरिगृहीतान् वा, तेषां वनस्पतिदेवता अभिकुञ्चयन्ति । अग्निवैजान्तो नाम, सोमः पितृमात्राम, स्वधिति शिवो नाम, आपो वरुणो नाम, भूमिनिवृत्तिनाम, गार्ध्वयत्राम, गोः रत्नोको नाम, देव पर्व(मा)नो नाम, आदित्यः पूषा नाम, दिशः काश्र नाम, इन्द्रो वरुणो नाम, वायु प्राणो नाम, ता वै द्वादश वनस्पतीनां देवताः । एता एव वनस्पतीन् घ्नन् ज्वन्ति । अथो आहुर्वनस्पतिमध्वे विवृक्षेयु ता एव देवताः स्थालीपाकैर्वधेते । अग्निमाज्येन, सोमं श्यामकेन, शिवं पायसेन, आपो दध्ना, भूमिं सप्तादकेन, ग्रामभूतैः गां वाग्निं पयसान् पिशितेन, पूषाणमात्राहैः, दिशो पयैः इन्द्रं हविष्यभोजनेनेति । अथो अस्या वनस्पतिदेवताः प्रजामेव प्रयच्छन्ति, या वनस्पतीन् न हिनस्ति । नास्या वनस्पतिदेवता जातहारिण्यो भवन्ति, या एवं वेदेति ॥ ६१॥

(का० सं० क० ६)

इसके बाद अब हम तिश्चीन जातहारिणीयों की व्याख्या करेंगे । ये प्रायः सज्जन व्यक्तियों को ही आक्रान्त करती हैं ।

हे वृद्धजीवक ! जो (स्त्री) वृद्ध को प्राप्त होते हुए शकुनी (पक्षी) को काटती है, माता अथवा मरदाती है, उसे महाग्रह वाली शकुनि जातहारिणी आक्रान्त करती है । वह (शकुनि जातहारिणी) काकी, भामसी, कुक्कुटी, मयूरी, चाषी (नीलकण्ठी), सारिका (पैना), तैलपायिका, उलूकी, भोलान्तिका, गृथी, रयेनी एवं भारद्वाजी आदि अनेक रूपों की होकर स्वप्न में अपूर्व (पहिले कभी नहीं देखी गई आकृतियों वाली) दिखाई देती है । गर्भिणी एवं सूतिका को भय दिखाती है, बालक को संतस्त करती है तथा महायोग, महाप्राण, घोररूप (भयंकर रूप), रौद्र (अति क्रोधित आकृति वाली), अनायतपक्षा (संकुचित पंखों वाली), वज्र-भट्ट (कठिन या सुदृढ़) चोंच, नख, दन्त तथा दंष्ट्रा वाली, वैदूय मणि की ज्वाला (अत्यधिक रक्तवर्ण) सदृश नेत्रों वाली, अत्यन्त विचित्र बड़े-बड़े पंखों वाली, कण्ठ में स्पष्ट तथा माण की विचित्र गुण वाली माता को घारण करने वाली, विभिन्न प्रकार के पुष्प, गन्ध, वस्त्र, मुसल एवं उज्ज्वल वस्तुओं को घारण करने वाली, श्रेष्ठ मुकुट धारण करने वाली, नपुसक, विकनकल, अंगद, कुण्डल, वामघण्टा, पलाका, आतपत्र(छाता) उल्का, विद्युत् एवं मेघमाला से अलंकृत यह भगवान् कुमार (कार्तिकेय) की ग्रानी(?) तथा बह्वन (के स्थान वाली जातहारिणी) स्वप्न में (स्त्री या बच्चे को) डराकर इसके बाद रोग को उत्पन्न कर देती है । उसके पश्चात् देपहर, अर्धरात्रि या दोनों संध्यारों में या (सबके) सो जाने के बाद बालगृह में उपर्युक्त अनेकों प्रकार की होकर छिप जाती है । जिससे बालक उच्च स्तर से चिन्विता है, रोता है, डरता है, काँपता है, ज्वरित होता है, ज्वर से पीड़ित होता है, बेचैन हो जाता है, नहीं बोलता, सूँछित हो जाता है, लड़खड़ा कर गिर जाता है, उसे सूजी सदृश वेदना होती है, शून्यता हो जाती है, अत्यधिक क्षय होता है या अन्य अनेक उपद्रव स्वरूप रोग हो जाते हैं । जो स्त्री स्वप्न में अत्यधिक शकुनी पक्षी को देखती है, उसे यह शकुनी जातहारिणी आक्रान्त करती है । उस (जातहारिणी आक्रान्त) स्त्री को अन्य वृद्ध स्त्री शकुनी के घोसेल में स्थित पुरीष से तथा पक्षोदक से अवसिञ्चन करें, यही इसका प्रायश्चित्त है । वह (शकुनी) अपने भागधेय से स्त्री को संतान युक्त करती है । जो इस तत्व को जानती है वह शकुनी को हत्या नहीं करती, एवं उसे शकुनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती ।

१. तिलचटा (अमकोष) या एक प्रकार की चिड़िया (मो० वि०)

हे वृद्धजीवक ! जो स्त्रियाँ गौ का हनन कराती हैं, या हनन करावती हैं एवं गोमांस का उपयोग करती हैं, उन्हें जातहारिणी आक्रान्त कर देती हैं। जिसमें गोमाता जातहारिणी से आक्रान्त होने से) वह (आविष्ट स्त्री) स्वप्न में गोपाल (गौओं के पालक) या बछड़े के पालक का दंड़पती है (या उस पर आक्रमण करती हैं), उसे असाध्य गोमाता जातहारिणी आक्रान्त करती हैं। कहा गया है कि इस (आविष्ट) उपवास की हुई स्त्री को गायों के मध्य में (बैठाकर) गोमूत्र एवं गोपुष्प लगाकर स्नान कराये यही इसका प्रायश्चित्त है। गौ अपने ही भगवधेय से इसे (स्त्री को) पुत्रवती करती है। जो गाय की हत्या नहीं करती एवं इस तत्व को जानती है, उसे गोमाता जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती। इसी प्रकार महिषी, अना, आँध (पेड़), गर्दभी, अश्व (घोड़ो), अश्वतरि (खच्चरी), उष्ट्री, सूकर, मूषिका, शुनी (कुत्ता), गालगोलिका (विशिष्ट प्रकार का सर्प), गोधा, विश्वम्पा (विशिष्ट प्रकार की विच्छू) एवं मृगी आदि को भी यही विधि है (अर्थात् इन इन जातहारिणियों से आविष्ट होने एवं निवृत्त होने की उपर्युक्त गोमाता सदृश ही विधि है)।

हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री घर में अथवा घर के बाहर विचरण करने वाली सर्पिणी की हत्या करती है अथवा उसका हनन करावती है, उसे सर्पिणी जातहारिणी आक्रान्त करती है, जिससे उसकी (जातहारिणी आक्रान्त स्त्री को) संतान की विष से मृत्यु हो जाती है। कहा गया है कि नागकुल में अथवा सौ वल्मीक के मध्य स्थित वल्मीक में सिञ्चन करे यही इसका प्रायश्चित्त है। वह (सर्प) अपने ही भगवधेय से इसे पुत्रवती करती है, एवं उसे सर्प जातहारिणी नहीं होती। जो इस तत्व को जानती है, वह सर्प को हत्या नहीं करती एवं उसकी संतान की विष से मृत्यु नहीं होती।

जो स्त्री मत्स्य, मकर^१, तिमिङ्गल (एक प्रकार की बहुत बड़ी मछली), नक्र (मार), शंख, शम्बूक तथा सुखनक (शुक्ति) आदि जलचर प्राणियों की हत्या करती है, इस अधर्म के कारण रेवती कुट्ट होकर उसकी प्रजा (संतान) का हनन करती है, (वह कुट्ट रेवती) पहिले मत्स्य, मकरो, शुकी या शङ्ख होकर स्वप्न में हति करती है (रोमांचित करती है), तत्पश्चात् उसे हनन करती है (आगत पहुँचाती है), उसकी संतान जलवास या अन्य विभिन्न रोगों द्वारा जल में नष्ट हो जाती है। कहा गया है कि रोहिणी नान के द्वारा ही इसका प्रतिवाद होता है, यही इसका प्रायश्चित्त है। जो यह जानती है, वह मत्स्य का हनन नहीं करती, उसे मत्स्य जातहारिणी नहीं आक्रान्त करती।

हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री ग्रहण को हुई (पकड़ी हुई) अथवा न ग्रहण की हुई वनस्पति की हिंसा करती है, उससे वनस्पति देवता कुट्ट हो जाते हैं। वैश्वानर नाम वाला अग्नि, पितृ नाम वाला सोम, शिव नाम वाला स्वधा, वरुण नाम वाला अप, निर्ऋति नाम की भूमि, विद्यत् एवं श्रुतक नाम की गौ, पवमान नाम वाला देव, पूषा नाम वाला आदित्य, काश नाम वाली दिशाँ, वरुण नाम वाला इन्द्र, प्राण नाम वाला वायु आदि बाह्य वनस्पतियों के देवता हैं। यही (उपर्युक्त बाह्य देवता) वनस्पतियों का हनन करने वाले का हनन करते हैं (हनन करने वाले को आक्रान्त करते हैं)। कहते हैं कि वनस्पतियों के मध्य में प्रविष्ट इन देवताओं की स्थालीपाक द्वारा पूजा करें। अग्नि की घृत के द्वारा, सोम की श्यामक (विशिष्ट घान्य) के द्वारा, शिव की पायस (जौ) के द्वारा, अप (जल) की दीघ के द्वारा, भूमि की सत्ता के द्वारा, गौ अथवा अग्नि की ग्रामधूप के द्वारा, पवमान (वायु) की पिशित (मांस) के द्वारा, पूषा की अन्न आदि के द्वारा, दिशाँ की मद्य के द्वारा तथा इन्द्र की हविष्य भोजन के द्वारा (अभ्यर्चना या पूजा करें)। जो स्त्री वनस्पतियों की हिंसा नहीं करती, उसे वनस्पति देवता संतान से युक्त करते हैं। जो (स्त्री) यह तत्व जानती है, उसे वनस्पति जातहारिणी नहीं होती।

These *tivāścīna jātahāriṇīs* usually attack gentle persons.

The woman who cuts, kills personally or makes others to kill a growing *śakunī* (bird)

१. सम्भवतः गालगोलिका उस काल में पचा जाने वाला चतुष्पाद सर्पाकृति कोई जीव हो, क्योंकि यहाँ चतुष्पाद जातहारिणियों का वर्णन है सर्पिणी आदि का नहीं।

२. मकर-एक प्रकार का समुद्री विकृताकारजीव, कभी कभी क्रॉकोडाइल, शक या डॉल्फिन का संदेह उत्पन्नक। नक्र-क्रॉकोडाइल (मो. वि०)

is attacked by ferocious *śakunī* (bird) *jātahāriṇī*. This *śakunī* assuming the shape of she-crow, *bhāṣṭ* (kind of prey, kite ?), hen, peahen, she blue jay, black-bird, *tailapāyikā* (a bird), she owl, *bhōlanikā* (a bird), she vulture, she hawk, she sky-lark and other unseen shapes comes to her dreams. If frightens pregnant and puerperal woman, terrifies the child. This *gratā* and sister of *Kāṭikēya* moving agitatedly or swiftly, breathing harshly, having dreadful angry looks and unsparated wings, possessing beak, nails, teeth and jaw strong or hard like *vajra* and eyes red like flame of *valdīrya māni* (specific red gem) alongwith freak and big wings, wearing in neck garland of typical qualities made with gold and gems; holding various flowers, perfumes, garments, pestle and other white articles, wearing excellent crown, *nūpuraka*, *vikambūkat*, *angada*, *kuṇḍāla* (all specific ornaments), holding big bell, banner or flag, umbrella, adorned with meteor, thunderbolt and coluts, frightens the woman or children in their dreams and then produces diseases. Attaining all above various shapes this *revatī* hides herself in child's room (*balagṛha*) during midday, midnight, twilight or when every body is sleeping, then the child cries loudly, weeps, gets frightened, has tremors, is terrified and feeble, becomes restless, does not speak, becomes unconscious, falls due to trembling, feels pain like pricking of needles or gets anaesthesia (local), has excessive emaciation and other disorders due to various complications. The woman who dreams too much about *śakunī* gets attacked by it. To this *jātahāriṇī* afflicted woman other old lady should bedew with feces obtained from nest or water obtained from a pot filled with feathers of this *śakunī*, this is its expiation. By this the *śakunī* provides her progeny with its own share or destiny. The one who knows this secret never kills the *śakunī* (birds) thus does not get attacked with *śakunī jātahāriṇī*.

The woman who kills personally or makes others to kill the cow and uses meat of cow is attacked by *gomāṭi jātahāriṇī*, due to this (influence of affliction) the woman dreams of attacking or over-running cow-head or calf-boy or making them run. She suffers from incurable *gomāṭi jātahāriṇī*. It is said that the afflicted woman after keeping fast should be made to sit amongst the cows and bathed after applying cow urine and cow dung, this is its expiation. The cow provides her progeny with its own share or destiny. The one who knows this secret does not kill the cow, thus is not attacked by *gomāṭi jātahāriṇī*. Similar is the process of attack and remedy of *mahiṣī* (she buffalo), *ajā* (she goat), *avi* (sheep), *gardhabhū* (she donkey), *aśvā* (mare), *aśvatarī* (she mule), *uṣṭī* (she camel), *sūkārī* (she hog), *mūṣikā* (she mouse), *śūni* (bitch), *galagolīkā* (a four legged snake like creature), *godhā* (guana), *vīśvambharā* (a variety of scorpion) and *mṛgī* (she deer) etc. *catuṣpādī jātahāriṇīs*.

The woman who kills herself or makes others to kill a snake creeping inside or outside the house, is attacked by *sarpīṇī jātahāriṇī*, her progeny dies due to snake venom. It is said that she should bedew either to snakes family or an aunt-hill situated amidst hundred aunt-hills, this is its expiation. The she snake provides her progeny with its own share or destiny. The one who knows this secret never kills the snake and her progeny does not die due to snake venom.

The woman when kills fish, *makara* (a sea monster sometimes confounded with croco-

dile, shark or dolphin), *timinga* (a variety of big fish), crocodile, (insect of) conch shell or slug and oyster etc. aquatic animals, then due to this unrighteous act, angered *revati* kills her progeny. Initially this *revati* assuming the shape of fish, crocodile, oyster or conch shell etc. titillates in dreams and then kills her, her progeny dies due to hydrophobia and other disorders within the water. It is said that bathing during *rohini nakshatra* planet is its retribution and expiation. The one who knows this never kills fish etc. and is never attacked by *matrī jātahārini*.

The woman when destroys the vegetation held in hand or free, then *vanaspati* dieties get annoyed. There are twelve *vanaspati* gods i.e. *agni* named *vaisvānara*, *soma* named *pitṛ*, *swadhā* named *śiva*, *ap* named *varuna*, *bhūmi* named *nirṛti*, *gau* named *vīrat* and *śloka*, *deva* named *pavanāna*, *aditya* named *pūṣā*, *dīśa* named *kāśha*, *indra* named *varuna* and *vāyu* named *pṛāṇa*. All these twelve dieties of *vanaspati* (flora) kill those who destruct the vegetation. It is said that those dieties situated amidst the vegetation should the worshipped with *śhālīpāka* (a dish of barley or rice boiled in milk used as an oblation). The *agni* should be worshipped with *ghṛta*, the *soma* with *śyāmāka* (barley and millet), the *śiva* with *pūṣasa* (rice boiled with milk and sweetened), the *ap* with curd, the *bhūmi* with *saptāṇa* (seven types of grains), *gau* or *agni* with *grāmādhīpa* (fumigation material used in villages), the *vāyu* with meal, the *pūṣā* with cereals, the *dīśas* with wine and *indra* with food for oblation. Woman who does not destroy vegetation, *vanaspati* diety gives her progeny. The one who knows this secret is not attacked by *vanaspati jātahārini*.

उपर्युक्त जातहारिणियों (दैवी, मानुषी एवं तिरश्चीन) के प्रवेश का परिणाम (Result of affliction by these jātahārins)

अधर्मस्यातिसंवृद्ध्या रेवती लघेतत्तरम् । लब्ध्वाऽन्तरमतिक्रुद्धा नानारूपैर्दशैर्दितैः ॥ ७० ॥

अत्येष्ट दारुणतरस्ततो हतिं प्रजा इमाः । यौगपद्येन भार्या वा भ्रियन्ते वा पृथक् पृथक् ॥ ७१ ॥

(का० सं० क० ६)

अधर्म की अतिवृद्धि के कारण (हो) रेवती अवसर प्राप्त करती है (अर्थात् शरीर में प्रविष्ट होती है) । अवसर पाकर (अन्तर प्रविष्ट होकर) अत्यधिक क्रोधान्न होकर उपर्युक्त (दैवी, मानुषी तिरश्चीनादि) अथवा अवर्णित अनेक प्रकार के दारुणतर रूपों को धारण करके स्त्री को सन्तानों का हनन करती है, साथ ही स्त्री को भी मार देती है अथवा दोनों (स्त्री एवं सन्तान) को पृथक् पृथक् मार देती है ।

It is only extreme unrighteousness which provides an opportunity to *revati*, which getting extremely angered and assuming earlier described or other very terrific shapes, kills the progeny of woman along with herself or else kills both these separately.

जातहारिणी लक्षण (Clinical features of jātahārins)

जातहारिणी आविष्ट होने पर सामान्य लक्षण (General clinical features)

अधर्मद्वारमासाद्य यदा विरति रेवती ॥ २४ ॥

नारीं तदा भवन्त्यस्या रूपाणीमानि जीवकः । । प्रत्यायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानि होयते ॥ २५ ॥

दृष्टिर्वाकुलतां याति यथाकालं न पुन्यति । भ्रष्टसत्त्वा निरत्नाहा कुक्षिशूलनिपीडिता ॥ २६ ॥

भवत्यप्रियरूपा च तैस्तै रोगैरुपहृता । विपरीतसमारम्भा विपरीतनिर्वाणिणी ॥ २७ ॥
उच्छिष्टा विकृता धृष्टा सवर्षेषु प्रवर्ति । अर्थासिद्धिर्न भवति संघट्टास्याः प्रत्ययते ॥ २८ ॥
गोत्राविमहिषीव्यस्या न जीवन्ति च वत्सकाः । अयशः प्राप्नुते घोरं वैधव्यं वा निगच्छति ॥ २९ ॥
कुलक्षयं वा कुरुते प्रसक्ता जातहारिणी ॥ ३० ॥ (का० सं० क० ६)

हे जीवक ! अधर्म द्वार से जब रेवती स्त्री के शरीर में प्रविष्ट होती है तो उसमें ये निम्न लक्षण होते हैं ।

उसके द्वारा (जातहारिणी के द्वारा) शरीर के प्रत्यान हो जाने पर (मुझ्झा जाने पर) ये लक्षण होते हैं :- दृष्टि में व्याकुलता हो जाती है, यथाकाल (उचित समय पर) पोषण नहीं होता, सत्व (धर्म) भ्रष्ट हो जाता है, (स्त्री) उत्साह रहित एवं कुक्षि के शूल से पीड़ित होती है । वह अग्रिय रूप की (विकृत आकृति की) हो जाती है, अनेक प्रकार के रोगों से उपहत हो जाती है (आक्रान्त हो जाती है) । वह सभी कार्य विपरीत रूप से प्रारम्भ करती है एवं विपरीत (वस्तुओं का) सेवन करती है । सभी प्रकार के कार्यों में उच्छुद्धल, विकृत एवं घट्ट रूप से प्रवर्तित होती है । उसे अर्थ (धन) की सिद्धि (प्राप्ति) नहीं होती, उसकी सम्पत्ति (धन एवं यश) लुप्त (नष्ट) हो जाती है । उसकी गौ, बकरी, भेड़ एवं महिषी के बच्चे जीवित नहीं रहते । उसे घोर अपयश प्राप्त होता है, वह विधवा हो जाती है तथा प्रसक्त हुई जातहारिणी उसके कुल का क्षय कर देती है ।

The *jātahārini* after entering inside the body through the pores created by unrighteous acts produces following clinical features.

Due to affliction by *jātahārini* the woman gets withered and has these clinical features :— bewildered looks, absence of nourishment in appropriate time, unsteadiness of psychology (*sarwa*) or decline in endurance, absence of enthusiasm, pain in abdomen, disfigureable looks and suffers from various disorders. She starts every work in opposite way and consumes opposite or non congenial edibles. She commences every work in unbridled way with impudence and abnormality. She does not get money, her property is lost. The calves of her cow, goat, sheep and buffalo do not survive. She gets badly defamed, becomes widow and *jātahārini* after seizing destructs her family.

(२) साध्यासाध्याता की दृष्टि से वर्णित जातहारिणियों के लक्षण (Clinical features according to classification based on prognosis)

(अ) साध्य जातहारिणी (Curable jātahārini)

दशैता जातहारिण्यो जीवमानासु मातृषु ॥ ४१ ॥

असाध्याः पुण्यातिन्यः साध्या गर्भोपघातिका ॥ (का० सं० क० ६)

जीवित माताओं में (अर्थात् जिनमें माता की मृत्यु नहीं होती) ये दस जातहारिणियाँ पुष्प (रजःस्राव) को घात (नष्ट) करने वाली असाध्य तथा गर्भोपघातक साध्य होती हैं ।

In alive mothers these are ten *jātahārini*s. Amongst these, those which cause destruction of *pūṣpa* (menstruation) are incurable and others destructing *garbha* are curable.

विमर्श (Comments)

यद्यपि यह साध्य जातहारिणियों का ही वर्णन है, फिर भी पुष्पघातिनी (शुष्का एवं कटम्भरा) को असाध्य लिखा गया है । संख्या उल्लेख में दस ही लिखा है पर विस्तृत वर्णन में ग्याह जातहारिणियों का उल्लेख है ।

Though the number has been given only as ten, yet eleven disease entities have been described under this category. Inspite of description being of curble *jātaḥārīṇīs*, those destructing the *pūṣpa* (menstruation i.e. *śuṣkā* and *kaṭambhārā*) are said to be incurable.

(१) शुष्क रेवती (*Śuṣka revatī*)

आषोडशवर्षमा या स्त्री पुष्यं न पश्यति ॥ ३१ ॥

प्रसूतबाहुकुचा तामाहुः शुष्कोरवतीम् ॥ (का० सं० क० ६)

पौंड्रश वर्ष को अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी जिस रजोदर्शन न हो, जिसके बाहु तथा नितम्ब प्रसूतान (पतले या क्षीण) हों, उसे शुष्क रेवती कहते हैं।

In this, the girl does not get her menses inspite of attaining the age of sixteen years,

her arms and hips are withered or emaciated.

(२) कटम्भरा (*Kaṭambhārā*)

विना पुष्यं तु या नाती यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३२ ॥

कृशा हौनन्बला कुक्का साऽपि चोक्ता कटम्भरा ॥ (का० सं० क० ६)

विना पुष्य (रजोदर्शन) के ही जो स्त्री यथाकाल (पूर्णायु) में नष्ट होती है (मरती है) एवं कृश, हौन बल वाली तथा कुब्ध (हर समय क्रोधित होने वाली) होती है, उसे कटम्भरा कहते हैं।

The woman who dies in her mature age without having menstruation, is emaciated,

weak and irritable is called as suffering from *kaṭambhārā*.

(३) पुष्यघ्नी (*Puṣyaghñī*)

वृथा पुष्यं तु या नाती यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३३ ॥

स्थूललेमशगण्डा वा पुष्यघ्नी साऽपि रेवति ॥ (का० सं० क० ६)

जो स्त्री यथासमय में व्यर्थ पुष्य का दर्शन करती है (अर्थात् अपने समय पर ही रजोदर्शन होता है परन्तु वह बेकार या बिना फल या गर्भ वाला होता है) तथा जिसका गण्डप्रदेश स्थूल एवं लोमयुक्त होता है उस रेवती को पुष्यघ्नी कहते हैं।

In this condition though the woman gets her menstruation however that is useless (or

she does not conceive), her cheeks are corpulent and covered with hair.

(४) विकृटा (*Vikṛtā*)

कालवर्णप्रमाणैर्या विषमं पुष्यमुच्छति ॥ ३४ ॥

अनिमित्तबललानिर्विकृटा नाम सा स्मृता ॥ (का० सं० क० ६)

जो स्त्री काल, वर्ण एवं प्रमाण में विषम पुष्य (रजोत्सव) वाली होती है (ऋतुस्राव काल में विषम अर्थात् शीघ्र या विलम्ब से, प्रमाण में विषम अर्थात् अति अल्प या अत्यधिक एवं वर्ण में विषम अर्थात् अत्यधिक रक्त वर्ण या कुष्माण्ण), एवं जिसे बिना किसी कारण के बल की लानि (हानि) होती है वह विकृटा नाम से जानी जाती है।

The woman suffering from this gets menstruation having irregularity in duration, colour and amount and feels exhausted without any cause.

(५) परिश्रुता (*Parishrutā*)

अभीक्ष्णं स्रवते यस्या नार्या योनिः कृशान्तरः ॥ ३५ ॥

परिश्रुतेति सा ज्ञेया नारीणां जातहारिणी ॥ (का० सं० क० ६)

जिस कृश (दुर्बल) स्त्री को योनि अभीक्ष्ण (तत्काल) एवं अत्यधिक) स्राव करती है, वह स्त्री को आक्रान्त करने वाली जातहारिणी परिश्रुता (नाम) से जानी जाती है।

Emaciated woman having constant and excessive discharges per vaginam is known as suffering from *parishrutā*.

(६) अण्डघ्नी (*Aṇḍaghñī*)

यस्यास्त्वालक्ष्यमालनमण्डं प्रपतति स्त्रियाः ॥ ३६ ॥

अण्डघ्नीमिति ह्याहुस्तां दारुणां जातहारिणीम् ॥ (का० सं० क० ६)

जिस स्त्री का आलक्ष्य (दिखाई देने वाला) एवं आलन (चिपका हुआ) अण्ड (गर्भित स्त्रीबीज) गिर जाता है, उस दारुण जातहारिणी को अण्डघ्नी कहते हैं।

This dreadful *jātaḥārīṇī* is that, in which scarcely visible adhered *aṇḍā* (zygote) is expelled (repeatedly).

(७) दुर्धरा (*Durdharā*)

नितिनिरृतदहङ्गो यस्या गर्भो विनश्यति ॥ ३७ ॥

दुर्धरा नाम सा ज्ञेया सुधोरा जातहारिणी ॥ (का० सं० क० ६)

जिस स्त्री का अत्यधिक प्रकट न हुए देहाङ्ग वाला गर्भ (अर्थात् जिस गर्भ के देहाङ्ग बन गए हैं पर स्पष्टतर नहीं हैं) नष्ट हो जाता है, वह धोरा जातहारिणी दुर्धरा नाम से जानी जाती है।

In this condition the embryo of woman whose body parts are not conspicuous is destroyed (repeatedly).

(८) कालरात्रि (*Kālātrī*)

सम्पूर्णङ्गं यदा गर्भं हस्ते जातहारिणी ॥ ३८ ॥

कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात् स्त्री तत्र जीवति ॥ (का० सं० क० ६)

जब जातहारिणी सम्पूर्णङ्ग गर्भ (सभी अंगों के विकसित होने के बाद का गर्भ) का हराण कर लेती है, उसे कालरात्रि कहते हैं। इसमें स्त्री बहुत ही दुःख से (कठिनाई से) जीवित रहती है।

When *jātaḥārīṇī* destroys the fetus possessing complete body parts, then it is known as *kālātrī*. In this the woman survives with great difficulty.

(९) मोहिनी (*Mohinī*)

यथा विषज्जते गर्भः प्रतीतो वाऽथ मुच्यते ॥ ३९ ॥

स्त्रीचिन्ताशया सा प्रोक्ता मोहिनी जातहारिणी ॥ (का० सं० क० ६)

जिसमें गर्भ संसक्त नहीं होता या संसक्त होकर गिर जाता है तथा साथ साथ स्त्री को मूर्च्छा आदि से आक्रान्त कर नष्ट कर देती है वह मोहिनी जातहारिणी है।

This is characterized with either non attachment of *embryo* or its expulsion after attachment alongwith death of woman due to unconsciousness.

(१०) स्तम्भनी (*Stambhani*)

यस्या न स्पन्दते गर्भः स्तम्भनी नाम सा स्मृता ॥ ४० ॥ (का० सं० क० ६)

जिस स्त्री का गर्भ स्पन्दन नहीं करता, उसे स्तम्भनी कहते हैं।

In this the fetus does not quiver.

(११) क्रोशना (*Krośanā*)

उदरस्थो यश्च क्रोशत् क्रोशना नाम सा स्मृता ॥ ४१ ॥ (का० सं० क० ६)

उदर-स्थित (गर्भ) जिसमें (जिस जातहारिणी में) क्रोश (उपद्रव) करता है, वह क्रोशना नाम से जानी जाती है।

When the *fetus* situated in *kruśi* (uterus) creates various complication then she is known as suffering from *krośanā*.

(आ) याप्य जातहारिणी (*Yāpya i.e. having tendency of relapse Jāvalāhāriṇīs*)

एतः षोडश निर्दिष्टा नामभिः कर्माभिः पृथक् । दारुणा जातहारिण्यो याप्या धर्मक्रियावताम् ॥ ४८ ॥

(का० सं० क० ६)

ये नाम एवं कर्म के अनुसार पृथक् पृथक् सोलह जातहारिणी वर्णित हैं, ये दारुण जातहारिणीयों धर्म-कर्म-युक्त स्त्रियों में पाए जाते हैं।

These are sixteen having different names and actions. In woman doing righteous acts these are *yāpya* or relapsable.

(१) नाकिनी (*Nākinī*)

जायते तु मृतं नित्यं यस्या नार्वाः सत्वे सत्वे ॥ ४२ ॥

नाकिनीमिति तां विद्याददारुणां जातहारिणीम् ॥ (का० सं० क० ६)

जिस स्त्री को नित्य मृत ही सन्तान उत्पन्न होती है, उस दारुण जातहारिणी को नाकिनी कहते हैं।

The dreadful *jāvalāhāriṇī* in which woman always delivers a dead child is known as *nākinī*.

(२) पिशाची (*Pīśācī*)

जातं जातमपत्यं तु यस्याः सद्यो विनश्यति ॥ ४३ ॥

पिशाची नाम सा योरा मांसदो जातहारिणी ॥ (का० सं० क० ६)

जिस स्त्री का उत्पन्न हुआ अपत्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है अर्थात् मर जाता है, वह मांस पक्षण करने वाली चोर पिशाची नाम की जातहारिणी है।

In this *carnivorous jāvalāhāriṇī* named *pīśācī*, the neonate of woman dies immediately after delivery.

अन्य १४ याप्य जातहारिणी (*Other 14 relapsable jāvalāhāriṇīs*)

द्वितीये दिवसे यक्षी, तृतीयेऽहनि चासुरी ॥ ४४ ॥

कलिनार्णम चतुर्थेऽहनि, पञ्चमेऽहनि च वारुणी । षष्ठेऽहनि स्मृता षष्ठी, सप्तमेऽहनि भीरुका ॥ ४५ ॥

अष्टमे दिवसे याप्या, मातंगी नवमेऽहनि । दशमे भद्रकालीति, तेद्री त्वेकादशेऽहनि ॥

द्वादशे वधिका प्रोक्ता, त्रयोदशे च त्रिपिडका ॥ ४६ ॥

कपालमालिनी नाम चतुर्दशे च रेवती । ततः पश्चात् परे काले विज्ञेया पित्तिपिच्छिका ॥ ४७ ॥

(का० सं० क० ६)

यद्यपि श्लोक में कहीं भी सन्तान की मृत्यु का स्पष्ट निर्देश नहीं है, फिर भी संदर्भ के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि सन्तान के जन्म के पश्चात् दूसरे दिन से लेकर पन्द्रह दिन की आयु का होने तक बारम्बार मृत्यु का कारण होने के ही आधार पर निम्न नाम दिए गए हैं।

These *jāvalāhāriṇīs* kill the children repeatedly after birth on specific days.

(३) यक्षी (*Yakṣī*)

(जन्म के) दूसरे दिन (घातक) यक्षी ।

Fatal on second day is *yakṣī*.

(४) आसुरी (*Āsurī*)

(जन्म के) तीसरे दिन (घातक) आसुरी ।

Fatal on third day is *āsurī*.

(५) कलि (*Kalī*)

(जन्म के) चतुर्थ दिन (घातक) कलि नाम की ।

Fatal on fourth day named *kalī*.

(६) वारुणी (*Vārūṇī*)

(जन्म के) पंचम दिन (घातक) वारुणी ।

Fatal on fifth day is *vārūṇī*.

(७) षष्ठी (*Ṣaṣṭhī*) -

(जन्म के) छठवें दिन (घातक) षष्ठी जानी गयी है।

Fatal on sixth day is known as *ṣaṣṭhī*.

(८) भीरुका (*Bhīrūkā*) -

(जन्म के) सप्तम दिन (घातक) भीरुका ।

Fatal on seventh day is *bhīrūkā*.

(९) याप्या (*Yāpyā*)

(जन्म के) आठवें दिन (घातक) याप्या ।

Fatal on eighth day is *yāmyā*.

(१०) मातङ्गी (*Māṅgī*)

(जन्म के) नवें दिन (घातक) मातङ्गी ।

Fatal on ninth day is *māṅgī*.

(११) भद्रकाली (*Bhadrakālī*)

(जन्म के) दसवें दिन (घातक) भद्रकाली ।

Fatal on tenth day is *bhadrakālī*.

(१२) रौद्री (*Raudrī*)

(जन्म के) ग्यारहवें दिन (घातक) रौद्री ।

Fatal on eleventh day is *raudrī*.

(१३) वरिधिका (*Varadhikā*)

(जन्म के) द्वादश दिन में (घातक) वरिधिका कही गई है ।

Fatal on twelfth day is said to be *varadhikā*.

(१४) चण्डिका (*Caṇḍikā*)

(जन्म के) तेरहवें दिन (घातक) चण्डिका ।

Fatal on thirteenth day is *caṇḍikā*.

(१५) कपालमालिनी (*Kapālamālinī*)

(जन्म के) चौदहवें दिन (घातक) कपालमालिनी नाम की रेवती है ।

Revatī fatal on fourteenth day is named *kapālamālinī*.

(१६) पिलिपिच्छिका (*Pilipicchikā*)

तत्पश्चात् एक पक्ष (पन्द्रह दिन) के काल में (घातक) पिलिपिच्छिका जानी जाती है ।

Later on fatal after one fortnight is known as *pilipicchikā*.

(३) असाध्य जातहारिणी (*Asādhya or incurable Jālaharīṇī*)

(१) वरया (*Varāyā*)

यस्यास्तु गर्भरूपाणि पञ्च षट् सप्त वा मुने ! । श्रियन्तेऽनन्तरं वरया असाध्या जातहारिणी ॥ ४९ ॥

(का० सं० क० ६)

हे मुनि ! जिस स्त्री के गर्भ रूप पंचम, षष्ठ या सप्तम मास में लगातार अन्दर ही मर जाते हैं (गर्भाशयान्तर्गत गर्भ को मृत्यु हो जाती है), वह असाध्य जातहारिणी वरया है ।

In this condition there is repeated intra-uterine death of fetuses in fifth, sixth or seventh month.

(२) कुलक्षयकरी (*Kulakṣayakārī*)

श्रियन्ते दारका यस्याः कन्या जीवन्त्यन्यतः । कुलक्षयकरी नाम साऽसाध्या जातहारिणी ॥ ५० ॥

(का० सं० क० ६)

जिस स्त्री के पुत्र मर जाते हैं एवं कन्याएं बिना यत्न किये ही जीवित रहती हैं, वह असाध्य कुलक्षयकरी नाम की जातहारिणी है ।

The woman whose sons die and daughters survive even without proper care is known to be suffering from *kulakṣayakārī jālaharīṇī*.

(३) पुण्यजनी (*Puṇyajānī*)

जातं जातमपत्यं तु यस्याश्च श्रियते स्त्रियाः । धोरा पुण्यजनी नाम साऽसाध्या जातहारिणी ॥ ५१ ॥

(का० सं० क० ६)

जिस स्त्री के अपत्य पैदा होते ही मर जाते हैं, वह भयंकर पुण्यजनी नाम की असाध्य जातहारिणी है ।

In dreadful *puṇyajānī jālaharīṇī* children of the afflicted woman die immediately after birth.

(४) पौरुषादिनी (*Pauruṣādīnī*)

श्रियत्रं श्रियतेऽपत्यं यस्याः प्राक् षोडशाब्दतः । पौरुषादिनी सा प्रेक्ता असाध्या जातहारिणी ॥ ५२ ॥

(का० सं० क० ६)

जिस स्त्री को सन्तान सोलह वर्ष (को अवस्था) को प्राप्त करने के पूर्व ही मर जाती है, उस असाध्य जातहारिणी को पौरुषादिनी कहते हैं ।

The progeny of the woman afflicted with *pauruṣādīnī jālaharīṇī* die before attaining the age of sixteen years.

(५) संदर्शनी (*Saṇḍarṇī*)

बिभर्त्यन्यं यदा गर्भं तदा पूर्वः प्रसीयते । संदर्शति वदन्त्येनामसाध्यां जातहारिणीम् ॥ ५३ ॥

(का० सं० क० ६)

दूसरे गर्भ के धारण करते ही पहिला (इस गर्भ से पहले ही उत्पन्न बच्चा) मर जाता है, इस असाध्य जातहारिणी को संदर्शनी कहते हैं ।

In this incurable *saṇḍarṇī jālaharīṇī*, immediately after conception the child born just before this conception dies.

(६) कर्कोटकी (*Karkoṭakī*)

गर्भेणैकं ग्रहेणैकं मृत्युनैकेन^१ युज्यते । एषा कर्कोटकीत्युक्ता दारुणा जातहारिणी ॥ ५४ ॥

(का० सं० क० ६)

स्त्री के गर्भवती होने पर (यमजों में से) एक सन्तान मर जाय और दूसरा बालग्रह से पीड़ित हो जाय, उसे कर्कोटकी नामक दारुण जातहारिणी कहते हैं ।

१. गर्भेणैका तथा मृत्युनैकेन (यु० पा०)

abnormalities, vaginal discharges and abortions or other pregnancy disorders. *yāpya* (relapsable) group includes stillbirths and neonatal deaths, while the last i.e. *asādhya* (incurable) group is the description of death of twins and other children at various ages.

Considering above etiology and symptomatology, it is not possible to establish congruity with any single entity known today. It is just possible, that whenever the scientists of that era failed in establishing role of *doṣas* in causation of diseases, they considered some divine power responsible for diseases and described all those conditions under this heading. The psychological fear of the *jātaḥārīṇī* may deter the pregnant woman from coming in close physical contact of others lest she becomes victim of infective disorders, besides she will also use balanced diet and mode of life, will not harm the animals or plants lest she injures herself. Husband will also lead normal or balanced life due to fear of this *jātaḥārīṇī*.

On the basis of specific symptoms the *jātaḥārīṇīs* may be correlated in following way :

Name of <i>jātaḥārīṇī</i>	Probable diseases
1. <i>Śuśka revatī</i>	Delayed menarche due to nutritional disorders.
2. <i>Kaṭambharā</i>	Primary amenorrhoea due to nutritional deficiency without influencing longevity.
3. <i>Puṣpaghñī</i>	Anovular menstruations associated with hirsutism.
4. <i>Vikula</i>	Irregularly irregular menstrual cycle.
5. <i>Parisruvā</i>	Excessive vaginal discharges (leucorrhoea).
6. <i>Angaghñī</i>	Abortion of very short gestational age (blastocystic stage).
7. <i>Durdharā</i>	Abortions during first trimester.
8. <i>Kālarātrī</i>	Premature deliveries associated with death of neonate.
9. <i>Mohinī</i>	Abortions due to diseases of the mother (toxæmia?).
10. <i>Sambhani</i>	Absence of quickening or stillness of fetus.
11. <i>Krośānā</i>	Pregnancy disorders (toxæmias?).
12. <i>Nākinī</i>	Repeated stillbirths.
13. <i>Piśāci*</i>	Neonatal death immediately after birth.
14. to 27. <i>Yakṣī</i> to <i>Pilipicchikā</i>	Repeated neonatal deaths from 2nd day of birth to fifteenth day.
28. <i>Vāśyā</i>	Intrauterine death of fetus in second trimester.
29. <i>Kulakṣayakarī</i>	Death of only male children.
30. <i>Puryajani*</i>	Death of child immediately after birth.

* both have similar description.

- | | |
|------------------------|---|
| 31. <i>Pauruṣālinī</i> | Death of child before sixteen years of age. |
| 32. <i>Samdamsī</i> | Death of child after next conception. |
| 33. <i>Karkotakī</i> | Death of one and affliction by <i>grahas</i> to the other child (out of twins) consequent upon achievement of conception. |
| 34. <i>Indravadaṇā</i> | Death of binovular twins. |
| 35. <i>Baḍavānukhī</i> | Death of uniovular twins. |



के कारण गर्भपात की संज्ञा दी है^१।

The expulsion of fetus upto fourth month of pregnancy is termed as *garbha-srāva* because the products of conception are liquid, there after in fifth and sixth months it is termed as *garbha-pāta*, because by this period the fetal parts have attained some stability or have become solid. Bhoja opines (quoted in Mādhukōṣa commentary of Mādhava Nīdāna) that the period of *garbha srāva* is upto three months.

विमर्श (Comments)

गर्भस्राव प्रक्रिया को देखते हुए भोज का वचन अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है, क्योंकि तीसरे मास तक अपरा तथा गर्भोदक के पूर्ण निर्माण न होने से स्राव में अधिकांशतः अपूर्णता रहती है एवं गर्भ का थोड़ा-थोड़ा अंश बाहर आता है, तत्पश्चात् गर्भोदक, अपरा तथा जरायु (एन्डोमेट्रिक कला) को सामान्य निर्मित के कारण गर्भ स्राव अधिकांशतः लघु-प्रसव सदृश ही सम्पादित होता है।

Explanation of Bhoja appears more logical because upto third month i.e. before complete formation of placenta, amniotic membrane and its fluid, the expulsion of products of conception usually occurs in pieces while after this period due to complete formation of amniotic bag the mechanism of abortion resembles miniature labour, which is probably the source of above description.

गर्भस्राव या पात का निदान (Causes of abortion)

ये ह्रस्व कुक्षौ वृद्धिहेतुसमाख्याता भावास्तेषां विपर्ययादुदरे विनाशमापद्यते, अथवाऽप्यचिरजातः स्यात् ॥
(च० सं० शा० ४/२९)

सा चेत्पतुष्प्रभृतिषु मासेषु क्रोधशोकामूद्यैर्भायत्रासव्याध्यायमसंक्षोभसंशयगणविषमश्रान (विषमासन-शु० पा०) शयनस्थानक्षुत्पिपासातिथेयात् कदाहासाद्वा पुंष पश्येत् ॥ (च० सं० शा० ८/२४)

ग्राह्यधर्मयानवाहनाख्यगमनप्रसङ्गलनप्रपदनप्रपीडनशान्तिभायतविषमश्रयानसोपवायसवेगोभिधातानिरुक्षकदुर्तिक-भोजनशोकातिशयसेवनानातिसात्वमनविरचेचनपेङ्खोलनार्जोगर्भश्रानतन्प्रभृतिभिर्विशेषैर्बन्धनान्मुच्यते गर्भः, फलमिव वृत्तबन्धनादभिघातविशेषैः ॥ (सु० सं० नि० ८/३)

कृमिवाताभिघातैस्तु तदेवोपद्रुतं फलम् ।

पातस्यकालेऽपि यथा तथा स्यात् गर्भविच्युतिः ॥ (सु० सं० नि० ८/९)

तत्र पूर्वोक्तैः कारणीः पतित्यति गर्भं ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)

स्त्री ज्वेदपद्मगर्भां परिहर्षायासेवेत । तत्र यस्या वसिष्ठापर्वश्रीणिगोनिमुखेषु शूलं पुष्पदर्शनं वा स्यात् ॥ ३॥

यस्याः पुनरतिमात्रदर्शोपचयाद्यशोर्कैर्वा व्यावायादिभिरन्यैर्वा व्याधिभिः पूर्वोपचितेन वा जनन्यपत्ययोः कर्मणा बन्धान्मुच्यते गर्भः फलमिव वृत्तात् ॥ (अ० सं० शा० ४/३ व २७)

गर्भिण्याः परिहर्षाणां सेवया रोगतोऽथ वा । (अ० ह० शा० २/१)

गर्भ-वृद्धि के जो हेतु बताए गए हैं यदि उनमें विकार या विपरीतता आ जाय तो गर्भ का उदर में ही विनाश हो

१. नरस्य स्त्रीस्वरत्वं वा स्त्रिया वा पुरुषस्वरात् (स) । अग्रे गर्भच्युतिं वापि गर्भव्यापतिर्जाच्युदुः ॥ (भे० सं० सू० ११/१५)
२. तथाश्चै गर्भजा गदाः । उच्यतेऽहकार्गः स्यात्तथा नागोदरः स्मृतः ॥
मकरो मूढगर्भश्च विषकम्मो गूढगर्भकः । जरायुदोषो गर्भस्य पातक्षप्यभकः स्मृतः ॥ (शा० सं० पूर्व० ७/१८०, १८१)

१. गर्भविद्धि इति अतिवचनावयवेन विशेषण द्रवरूपतया गर्भविद्धो भण्यते; स्रावो नातिवन्त्वात्, पातस्तु घनत्वात् । यत्तु भोजेऽभिहितम् - "आतृतीयातरो मासादग्रेः स्रावति शोणितम् । ऊर्ध्वं संघातस्तुस्तु गर्भः पतति योषिताम् ।"
(मा० नि० ६४/२ की मधु० व्याख्या)

महर्षि भेल ने पुरुष का स्त्रीस्वरत्वं, स्त्री का पुरुषस्वरा होना तथा आगर्भ की च्युति होना आदि विकारों को गर्भ-व्यापति के कारण माना है^१।

शाङ्गधर ने गर्भ-व्यापत् के अन्तर्गत उपविद्धक, नागोदर, मककल, मूढगर्भ, विक्रमभ, गूढगर्भ, जरायु-दोष तथा गर्भ-पात आदि आठ गर्भ रोगों का नामोल्लेख तो किया है परन्तु इनके विशिष्ट लक्षणों आदि का वर्णन नहीं दिया। अन्य संहिताओं में यद्यपि गर्भ-व्यापद् की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई परन्तु गर्भ को आक्रान्त करने वाले विभिन्न विकारों का वर्णन दिया गया है। इस अध्याय के अन्तर्गत गर्भ को आक्रान्त करने वाले उन्हीं विकारों का वर्णन किया जा रहा है।

Feminine voice of male, masculine voice of female and expulsion of *āma garbha* are due to disorders of fetus is the opinion of Bheela. Śārngadhara has enumerated eight disorders i.e. *upavistaka*, *māgodara*, *makkalla*, *mūdhagarbha*, *viskam̐bha*, *gūdhagarbha*, *jara-* *yudōṣa* and *garbhapāta* etc. under the heading of *garbhavyāpat* without elaborating these any further. Though in other texts of *āyurveda* one does not come across specific disorder under this heading, however, for the sake of description all the conditions (excepting teratologic abnormalities) affecting fetus are described in this chapter.

गर्भस्राव एवं गर्भपात (Garbhasrāva and garbhapāta or abortion of first or second trimester)

गर्भ-स्राव एवं पात की परिभाषा (Definition of garbha srāva and pāta)

आचतुर्थात् ततो मासात् प्रसवेद् गर्भविच्युतिः । ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठ्योः ॥

(सु० सं० नि० ८/१०; मा० नि० ६४/२; भा० प्र० चि० ७०/७२ एवं० यो० २०)

स्त्री गर्भं यो नित्यं; बाद के तीनों में गर्भविच्युति के स्थान में गर्भविद्धकः)

चतुर्थ मास तक गर्भ-विच्युति (स्वस्थान से अलग होकर गिरना) होने पर स्राव होता है (द्रव रूप होने के कारण) तथा पाँचवें एवं छठे महीने में शरीर हो जाने पर उसका पात होता है, अर्थात् चतुर्थ मास तक की गर्भ-च्युति को गर्भ-स्राव तथा पाँचवें एवं छठे महीने की गर्भ-विच्युति को गर्भ-पात कहते हैं।

मधुकोष व्याख्याकार ने भोज का वचन उद्धृत करते हुए गर्भस्राव की मर्यादा तीन माह तक तत्पश्चात् संघातपूत होने

जाता है अथवा वह अर्थात् शीघ्र ही (समय से पूर्व गर्भ-स्त्राव या पात रूप में) उत्पन्न हो जाता है।

चतुर्थ मास से लेकर (अग्रे आठवें मास तक) क्रोध, शोक, दूसरे को निन्दा या असंतोष, इर्ष्या, भय, शर्म, व्याघ्राय, व्याधाम (अत्यधिक) संश्लेष, संघारण (वेग-विधारण), विषम रूप से या विषम स्थान में बैठने, सोने या खड़े होने, पूछ एवं घास का अतियोग (अत्यधिक निरोध करना) तथा कदाहार (कुत्सित या सड़े गले आहार) के सेवन से स्त्री को पुष्प-दर्शन (रक्तस्त्राव) होने लगता है। अन्य भी महर्षि चरक ने शुक्र के दोषों से गर्भस्त्राव या पात होने तथा वायु की विकृति से गर्भ के नाश होने का वर्णन किया है।

पूर्व वर्णन में गर्भ के सम्पूर्ण देह, समय से एवं सुख पूर्वक उत्पन्न होने के लिए शुक्र, अमृक, आत्मा, गर्भाशय एवं ऋतुकाल का सम्पर्क होना (अर्थात् शुद्ध एवं सामान्य होना) तथा अन्य हित आहार-विहार एवं उपचार का होना कारणभूत बताया है।^१ उपर्युक्त सभी भावों में विकार होने से गर्भ अपने समय में न होकर उसके पहिले भी उत्पन्न हो सकता है अर्थात् शुक्र, आर्तव, आत्मा, गर्भाशय, ऋतुकाल तथा माता के आहार-विहार के विकार भी गर्भ-स्त्राव या पात के कारण हैं।

महर्षि सुश्रुत ने गर्भस्त्राव तथा मूढगर्भ के निदानों का एक साथ वर्णन करते हुए लिखा है कि (अत्यधिक) मैथुन, यान (रथादि की सवारी), वाहन (अथवादि की सवारी), अध्यागमन (पैदल चलना), प्रसूतलन (लड़खड़ाना या टोकर लगाना), प्रपन्न (प्रसाद आदि ऊँचे स्थान से तैरते से गिर जाना), प्रपीडन, धावन, अभिघात (शस्त्र, तोड़ या कोई आदि से प्रहार), विषम स्थान में शयन एवं बैठना, उपवास, वेगभिघात, अतिशय, कटु एवं तिक्त भोजन, शोक, क्षार का अतिसेवन, अतिसार, वमन एवं विरेचन (का अतिप्रयोग), प्रेङ्खलन (छूले में झूलना), अजीर्ण, एवं गर्भातक औषधियों के प्रयोग से गर्भ अपने बन्धनों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार कि अभिघात आदि से फल अपने वृत्त के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

पुरच संक्षेप में कहा है कि जिस प्रकार कृमि, वात एवं आघात से उपद्रुत होकर फल अकाल में गिर जाता है उसी प्रकार (कृमि, वात तथा आघात के कारण) गर्भ की भी विच्युति हो जाती है।

अन्य लिखा है कि माता के मानसिक और अगातुक दुखों के कारण तथा व्याधियों से (गर्भ अपनी स्वयं की व्याधियों से) पीड़ित होने के कारण कुक्षि में गर्भ को व्यापति होती है।^१ यद्यपि यह वर्णन गर्भाशयांतर गर्भ की मृत्यु के कारणों का है फिर भी "कुक्षि में गर्भ को व्यापति या कष्ट" इस वाक्य से इसे गर्भस्त्राव के कारणों के अन्तर्गत भी निहित कर सकते हैं।

पूर्व पृष्ठों में रजःस्त्राव के तीसरे दिन संभोग से गर्भाधान होने पर गर्भस्त्राव तथा पचीस वर्ष से कम आयु के पुरुष

१. कदाहारः कुत्सितहारः। (च० सं० शा० ८/२४ की चक्र० टीका)
२. शुक्रस्य दोषात्। न चास्य जायते गर्भः पतति प्रसवत्यपि॥ (च० सं० सू० २८/१८)
३. च० सं० सू० १२/८ (पृष्ठ १७७)
४. शुक्रासृगान्नाशयकालसंपदं मर्योपचारश्च हितैस्तथाऽन्यैः। गर्भश्च काले च सुखी सुखं च सञ्जायते संपरिपूरितः॥ (च० सं० शा० २/६)
५. पूर्वैर्लैरिति मूढगर्भनिदानैर्गर्भमर्धमनवाहनादिभिः॥ (सु० सं० शा० १०/५७ की डल्ल० टी०)
६. यानं रथादि, वाहनमथवादि, अध्यागमनं पदस्य मार्गगमनं, प्रपन्नं प्रसाददेः सकाशादतिशयेन पतनम्। अभिघातः शस्त्रतोदकशादिभिः प्रहारः (सु० सं० नि० ८/३ की डल्ल० टी०)
७. मानसागजुभिर्मानुषपातैः प्रपीडितः। गर्भो व्यापद्यते कुक्षी व्याधिभिश्च प्रपीडितः॥ (सु० सं० नि० ८/१३, मा० नि० ६४/९)
८. सु० सं० शा० २/३१ (पृष्ठ ७०)

द्वारा सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री में गर्भाधान करने से गर्भ को कुक्षि में ही व्यापति होने अर्थात् सक्रित भी हो सकने का उल्लेख किया है।

गर्भिणी स्त्री के साथ मैथुन करने से गर्भ को पीड़ा होती है,^२ परिणाम स्वरूप गर्भ का स्त्राव अथवा पात भी हो सकता है।

अष्टांगसंग्रह में लिखा है कि यदि आपन-गर्भा स्त्री (गर्भवती स्त्री) परिहार्य (वर्ज्य आहार-विहार) का परित्याग नहीं करती तो उसे श्रोणि एवं योनिमुख में शूल तथा पुष्प-दर्शन (रक्तस्त्राव) आदि हो जाते हैं अर्थात् गर्भस्त्राव होने लगता है। इन्होंने भी महर्षि सुश्रुत के सदृश ही मूढगर्भ एवं गर्भस्त्राव के निदानों का एक साथ वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भवती स्त्री में दोषों के अतिमात्र संचय हो जाने से, पूर्वोक्त मैथुन आदि (गर्भिणी द्वारा परित्याग्य आहार विहार) या अन्य व्याधियों के कारण अथवा माता या गर्भ के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण गर्भ अपने बन्धनों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार कि फल अपने वृत्त से मुक्त हो जाता है। टीकाकार इन्द्र ने स्पष्ट किया है कि गर्भ के पोषण के लिए स्थित माता के बन्धनों से मुक्त होकर वह गर्भ आम के साथ शोणित युक्त होकर प्रसृत हो जाता है अर्थात् आम-गर्भ का स्त्राव हो जाता है।^३

अष्टांगहृदयकार ने बहुत ही संक्षेप में लिखा है कि परिहार्य (त्याग्य आहार विहार) के सेवन से तथा अन्य योगों से गर्भस्त्राव हो जाता है। टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है कि स्वभाव, अपथ्य, सर्षप शाक एवं मन्दक दधि आदि का अत्यधिक सेवन, देश, काल आदि किसी भी कारण से योग हो सकते हैं जो गर्भ स्त्राव का कारण बन सकते हैं।^४ पूर्व वर्णन में आचार्य ने अतिव्याय आदि लगभग सुश्रुतादि लिखित सभी निदानों का गर्भिणी के लिए वर्ज्य आहार-विहार के अन्तर्गत वर्णन किया है एवं वहीं यह स्पष्ट भी कर दिया है कि इनका परित्याग न करने से आम-गर्भ का स्त्राव हो सकता है।^५

महर्षि भेल ने गर्भ-व्यापतियों का कारण संक्षेप में विंशति योनिदोषों को ही बताया है।^६

महर्षि हारीत ने लिखा है कि वातादि दोषों के प्रभाव के कारण वात से प्रेरित गर्भ दसवें मास के पूर्व में भी उत्पन्न हो जाता है^७ अर्थात् वातादि दोषों के विकार से गर्भ का स्त्राव या पात हो जाता है।

आचार्य भावमिश्र ने गर्भ-स्त्राव या पात के कारणों का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है कि (अत्यधिक) मैथुन, अध्यागमन (पैदल चलना), यान (रथादि की सवारी), आयास (परिश्रम), या प्रपीडन (टबाना), ज्वर, उपवास, उत्तान (ऊँचे से गिर जाना), प्रहार (चोट), अजीर्ण, धावन (तेज दौड़ना), वमन या विरेचन के प्रयोग, कुंथन, गर्भातन द्रव्यों के प्रयोग, तीक्ष्ण, क्षार, उष्ण, कटु, तिक्त तथा रक्ष द्रव्यों के सेवन, वेगभिघात, विषम स्थान में शयन या आसन (बैठने)

१. सु० सं० शा० १०/५४, अ० सं० शा० १/५ (पृष्ठ ८२)
२. सु० सं० चि० २४/१२३ (पृष्ठ ८३)
३. गर्भस्य बन्धनं यत्र तत्र मातुरज्बन्धो भवति परिपोष्य स व्यापन्नो गर्भः आमः सम शोणितगर्भेणापि प्रसूयते। (अ० सं० शा० ४/२७ की इन्द्र टी०)
४. अथवा योगातः पुष्पे दृष्टे, रोगस्य च स्वभावपथ्यसर्षपशाकमन्दकद्रव्यादेराहारान्मादेशकालविक्रान्ता सम्भवः। (अ० सं० शा० २/१ की अरुण० टी०)
५. अ० सं० शा० १/४४ से ४७ (पृष्ठ २२८, २२९)
६. ये च ते विंशतिः प्रोक्ता योनिदोषाः(ः) त्रिक्रित्तिते। एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्गर्भैर्वापाद्यते स्त्रियाः॥ (भे० सं० शा० ३/४)
७. अथ दोषबलेनापि गर्भो नापि प्रसूयते। वातसंप्रेरिते गर्भे अपूर्णं दिक्सेयदि॥ २४॥ प्रसूयते वाप्यथ तद्गर्भं नातः प्रदूयते॥ (हो० सं० षष्ठ्यां १/२४ व २५)

एवं भय के कारण गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है^१। अभिघात, विषमभोजन एवं पीडन आदि से पेड़ से पके फल के अकाल पत के सदृश ही गर्भ वृत्तक्षण तथा अकाल में ही गिर जाता है^२। वात के अस्सी विकारों में गर्भनाश का उल्लेख है^३ अर्थात् वायु-प्रकोप गर्भनाश (गर्भशयानर गर्भ-मृत्यु या गर्भस्राव) का कारण है।

माधवनिदान एवं योगरत्नकराकार ने लिखा है कि भय एवं अभिघात से तथा तीक्ष्ण एवं उष्ण अन्नपान के सेवन से गर्भ-पात हो जाता है। अभिघात, विषमभोजन एवं पीडन आदि से पेड़ से पके फल (के अकाल-पात) सदृश गर्भ (अकाल में) क्षण-मात्र में ही गिर जाता है^{४,५} मधुकोषव्याख्याकार ने भयाभिघातदि को उत्पक्षणा मात्र मानकर सुश्रुतीक ग्रन्थधर्म, यानादि कारणों के भी समावेश का निर्देश दिया है^६।

प्रकृषित वायु के शुक्रस्य होने पर भी गर्भ के स्राव या पात होने की सम्भावना होती है^७।

Caraka says that abnormalities in the factors responsible for proper growth and development of fetus mentioned earlier can cause either intrauterine death of the fetus or its expulsion before viability.

After fourth month of pregnancy anger, grief, calumny or discontent, jealousy, fear, terror, excessive coitus and exercise, irritation, suppression of natural urges, sitting, standing and sleeping on uneven place or in abnormal postures, excessive suppression of thirst and hunger, and use of stale food cause bleeding per vaginum or abortion. Abnormalities of *śukra* and *vāyu* are also causative factors, normal status of *śukra* (sperms), *asṛk* (ovum and ovarian hormones), *ātmā, āśaya* (uterus), *rukāḍā* and use of congenial dietetics are responsible for delivery of fetus in its proper mature period or in other words abnormalities in these factors can cause abortion.

Suśruta mentioning etiology of obstructed labour and abortion together says that due to coitus, travelling in carriage, riding on horse etc., journey on foot, staggering or stumbling, falling from height as palace etc., compression, running (very fast), trauma by weapon, stone or whips etc., sleeping or sitting in uneven place, fasting, suppression of natural urges, consumption of excessive dry, hot or pungent diet, grief, diarrhoea, excessive use of *kṣāra* (alkalies), emetics and purgatives, swinging, indigestion and use of abortifacient

१. ग्रन्थधर्मवर्णनग्रन्थनायासप्रतीकः । चक्रोपबालोत्तमप्रहाराजीर्णधर्मानैः ॥ ६९॥

कमनाञ्च विरेकाच्च कुञ्चनात् गर्भपातनात् । तीक्ष्णक्षारोष्णकटुकतिक्ष्णनिषेवणात् ॥ ७०॥

वेगीभिघातद्विषमादसनाच्छयनाद्भयान् । गर्भे पतति ॥ ७१॥

(गर्भपातनाद्-गर्भपातनिषेवेन गर्भपातशीलं द्रव्यम्-टीका) ॥ (पा० प्र० चि० ७०)

२. गर्भोऽभिघातविषमभोजनपीडनाद्यैः । पक्वं द्रुमसिद्धं फलं पतति क्षणेन ॥ ७३॥

(यथा वृत्तलानं पक्वं फलमभिघातेनकाले एव पतति, तथा गर्भोऽप्यभिघातादिनाऽकाले पतति-टीका) ॥ (पा० प्र० चि० ७०)

३. पा० प्र० चि० २४/१५

४. भयाभिघातत् तीक्ष्णोष्णपानशाननिषेवणात् । गर्भो पतति पतति क्षणेन ॥

(पा० प्र० सदृश ही; पा० नि० मूढगर्भं ६४/१ व ३; यो० १० स्त्री-गर्भ ते०)

५. यथा वृत्तलानं पक्वफलमभिघातेनकाले एव पतति, तथाकेतुभिर्पकाले गर्भपातः ॥ (पा० नि० ६४/३ की मधु० व्याख्या)

६. भयाभिघातादित्यादि । एतच्चोपलक्षणं, तेनान्येऽपि सुश्रुतीका ग्रन्थधर्मनायासप्रहाराजनास्तखलनादयो बोद्धव्याः ॥

(पा० नि० ६४/१ की मधु० व्याख्या)

७. च० सं० चि० २८/३४; अ० सं० नि० १५/१५-१६; अ० नि० १५/१३ (पृष्ठ १७७-१७९)

drugs, the fetus gets detached from its bonds in the same way as a fruit gets detached from its stalk due to trauma. As a fruit falls down untimely due to effect of *kṛmi* (insects / parasites), *vāta* (wind) and *ābhāta* (jerk or trauma), similarly fetus also gets detached due to influence of all these factors. Physical and psychological disorders of mother and disorders of fetus are also said to be responsible for producing fetal complications including abortion. The conception occurring on third day of menstrual cycle, or by a man of below twentyfive or in a woman of below sixteen years of age is also expelled. He writes further that coitus with a pregnant woman troubles the fetus, thus it may get aborted.

Both the Vāgbhāṭas say that if the woman does not give up contraindicated things the abortion occurs. Vāgbhāṭa I further writes that due to excessive accumulation of *doṣas*, non-avoidance of contraindicated articles, due to diseases or influence of deeds of previous life of either the mother or the fetus, the fetus gets detached from its bonds in the same way as a fruit gets separated from its stalk. Indu opines that the fetus gets detached from the bonds existing for its nourishment. Arunadatta has included nature, use of non-congenial diet, mustard (leaf) etc. vegetables and slowly formed curd, place of living and time factor as causes of diseases which may initiate abortion.

Bhela says that all the twenty *yoni-vyāpāt* can cause abortion while Hārta holds vitiated *doṣas* specially *vāta* responsible.

Views of Bhāvaprakāśa, Yogaratnakāra and Mādhava Nīdāna are almost identical to Suśruta. In Bhāvaprakāśa *garbhinaḥ* is enumerated as one of the eighty disorders of *vāta* or *vāta* is responsible for abortions.

Aggravated *vāyu*, located in *śukra* causes abortion.

विमर्श (Comments)

गर्भ-व्यापद् के अन्तर्गत गर्भ के जन्मजात विकारों के अतिरिक्त उन सभी व्याधियों का वर्णन किया गया है जो गर्भ को आक्रांत करती हैं। गर्भस्राव एवं गर्भपात के अतिरिक्त उपशुक्रादि आठ व्यापदों का वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया जायगा। इनके अतिरिक्त जातहरिणी प्रकरण में वर्णित अण्डज्नी, दुर्धरा, कालरात्रि तथा वयरा जातहरिणियों में अत्यधिक प्रारिभ्यक अवस्था के गर्भ से लेकर दूसरे त्रैमास तक के गर्भस्राव का ही वर्णन है तथा स्वप्नमी, मोहिनी, क्रोशना जातहरिणियाँ भी विभिन्न गर्भ-विकारों की ही ओर इंगित करती हैं^१, इनके अतिरिक्त निम्न योनिव्यापद् भी विभिन्न अवस्थाओं के गर्भस्राव या पात का ही मुख्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं जैसे-

(१) पुत्रज्नी- महर्षि चरक व सुश्रुत ने इस योनिव्यापद् का स्वरूप उल्लेख हुए या स्थित हुए गर्भ का विनाश कहा है^२।

(२) वामिनी- यद्यपि अन्य आचार्यों ने इस रोग में केवल शुक्र के ही योनि द्वारा वमन का वर्णन किया है परन्तु

१. का० सं० कल्प० ६३६ से ४९, ४९॥ (पृष्ठ ३१९, ३१२, ३१४)

२. (अ) तीक्ष्णद्वारयुक्ता गर्भं जातं जातं विनाशयेत् । दुष्टशोणित्वं नाद्याः पुत्रज्नी नाम सा मता ॥

(अत्र च यद्यपि सामान्येनैव गर्भाविनाश उक्तः, तथापि पुत्रस्यैव प्राधान्यात् 'पुत्रज्नी' इति व्यपदेशो हेयः- चक्र०)

(च० सं० चि० ३०/२८)

(आ) स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रज्नी रक्तसंवेदात् (स्थितं स्थितं गर्भं हन्ति नोत्तमप्रमाद-इत्त० टी०) ।

(सु० सं० उ० ३८/१३)

महर्षि सुश्रुत ने 'रज से युक्त शुक्र' के वमन का वर्णन दिया है जिसे बहुत ही प्रारम्भिकस्थ का गर्भस्राव भी मान सकते हैं।

(३) असृजा या अप्रजा- महर्षि चक्र ने असृजा योनि के लक्षणों में लिखा है कि गर्भ प्राप्त होने के बाद भी रक्तस्राव होता रहता है, टीकाकार चक्रपाणि ने पाठभेद 'अप्रजा' का उल्लेख करते हुए गर्भ के न ठहरने अर्थात् गिर जाने के लक्षण का भी समन्वेष किया है।^१

चौक उपर्युक्त वर्णित तीन योनिव्यापद भी गर्भस्राव के ही प्रतीक प्रतीत होते हैं, अतः गर्भ-स्राव या पात के निदान के विषय में विचार करते समय योनिव्यापद के निदानों का भी समन्वेष करना पड़ेगा। सभी आचार्यों ने योनिव्यापद के मुख्य चार कारण माने हैं (१) मिथ्याचार, (२) अर्तवदोष (३) बीजदोष (४) दैव प्रकोप।^२ जातहारिणी का कारण भी एक अदृश्य शक्ति का शरीर में प्रवेश है, अतः गर्भसंवातान्तर्गत वर्णित निदान, योनिव्यापद-निदान तथा जातहारिणी-निदान सभी को एक साथ विचार कर गर्भस्राव-कारक कारणों का विश्लेषण किया जाय तो संक्षेप में निम्नलिखित कारणों को गर्भस्राव या पातोत्पादक कहा जा सकता है:-

१. अज्ञात कारण-दैवी प्रकोप, जातहारिणी-प्रवेश, आत्मदोषादि।

२. गर्भ से सम्बन्धित कारण-

अ. जिनैतिक या क्रोमोसोम के विकार या बीजदोष।

आ. औपसर्गिक व्याधियाँ या कृमि-जन्य विकार।

इ. अन्य व्याधियों से पीड़ित गर्भ।

३. माता से सम्बन्धित कारण-

अ. स्त्री-जनान्त्रों के रचनात्मक घटकों के विकार यथा गर्भाशय एवं योनि के दोष।

आ. गर्भाशय-मसंपेशियों की अत्यधिक उत्तेजना या क्रियाशीलता-

१. अतिसारादि एवं वेग-विधारण से उत्पन्न प्रत्यावर्तन क्रिया-जन्य गर्भाशय-मसंपेशी उत्तेजना।

२. यान, वाहन, शारीरिक आघात, धावन, प्रयत्नादि तथा अतिसारादि में अत्यधिक कुंथन एवं विषम स्थान-श्रयानादि के कारण आकस्मिक उत्तराहुता-भार-वृद्धि हो गर्भाशय-पेशी उत्तेजना।

३. वात-विकार या गाड़ी-कार्य विकार।

इ. स्त्री के अङ्गस्रोतों के विकार-

१. काल दोष अर्थात् ऋतुव्यतीत काल में गर्भाधान होने पर सम्भवतः गर्भाशयात्तःकला में अङ्गस्रोतों का प्रभाव कम हो जाने से गर्भ के आधान की क्रिया में विषमता हो गर्भस्राव।

२. अर्तव दोष अर्थात् स्त्री के अङ्गस्रोतों के विकार।

इ. आकस्मिक शारीरिक आघात यथा यान-वाहनादि का प्रयोग, प्रसूचन आदि।

उ. जनान्त्रों में स्थानिक आघात यथा अतिव्याधाय।

ऊ. स्त्री के मानसिक विकार या साइकोजेनिक यथा क्रोध, शोक, भय, वेग-विधारण एवं अन्य मानसिक उपताप। अतिव्याधाय मानसिक विकृति द्वारा भी गर्भस्राव-कारक हो सकता है।

१. सत्वामुद्रिगेद बीजं बामिनी रजसायुग्म। (बीजम् शुक्रम्, उद्रिगेदं वमेत्। रजसा युतम् अर्तवमिश्रम्-उत्सृज्यं टी०) (सु० सं० ३८/१३)

२. रक्तपित्तकौर्तवा रक्तं पित्तेन दूषितम्। अतिप्रवर्तते योन्त्यां लब्धे गर्भेऽपि सासृजा ॥ १६॥

(गर्भे लब्धेऽपि रक्तमतिप्रवर्तते तेनारस्या गर्भो न तिष्ठति, ... दे तु साऽप्रजा इति पठन्ति-चक्र० ॥) (च० सं० वि० ३०/१६)

३. च० सं० वि० ३८/८; सु० सं० ३८/१८, ६।

ए. स्त्री का पोषण-वैषम्य-

१. अतिसारा, वमन, विरेचनादि से पोषक तत्वों का वहिःनिस्सरण।

२. कदाहार, अतिरस, तित्क, कटु भोजनादि अर्थात् असम्यक् पोषक तत्वों वाला भोजन।

३. क्षुधा-निरोध एवं उपवास।

ऐ. स्त्री की सावैदिक व्याधियाँ यथा औपसर्गिक या कृमि-जन्य व्याधियाँ, अन्य आतप आदि तथा वातादि दोष के विकार।

ओ. स्त्री की अवस्था जन्म यथा काल-वैषम्य अर्थात् अति बाला या वृद्धा में गर्भाधान होने पर भी गर्भस्राव होने की संभावना रहती है।

औ. गर्भनाशक या गर्भपातक औषधियों का प्रयोग यथा कटु, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्यों, क्षार तथा गर्भनाशक औषधियों का प्रयोग।

उपर्युक्त गर्भस्रावादि के कारणों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक पुस्तकों में वर्णित लगायत सभी कारणों का उल्लेख आचार्यों ने कर दिया है।

Expulsion of fetus from very early or blastocystic stage to second trimester is the main clinical feature of *andughnī*, *dardharā*, *kālāvarī* and *vaśyā* etc. *jālaharīnī*, similarly *putraghni* (repeated abortion of *sthita garbha* or after fourth month), *vāmanī* (expulsion of *raja* alongwith *śukra* or very young zygote) and *asrayā* or *aprayā* (abortion due to bleeding after conception) etc. *yonyāpād* also denote repeated abortion. Thus while considering the etiology of abortion causes of *yonyāpād* have also to be considered. *Mithyācāra*, *āraṇadōṣa*, *bijadōṣa* and *daiva-prakopa* are main causes of *yonyāpād*. Taking into account the causes of abortions, *yonyāpād* and also *jālaharīnī* following factors may be held responsible for abortion.

- 1) **Unknown or idiopathic**—Curses of god, infliction by *jālaharīnī* and effect of deeds of previous life.
- 2) **Fetal factors**—
 - a) Genetic or chromosomal defects or *bijadōṣa*.
 - b) Fetal infections or *kṛmī*.
 - c) Other diseases of fetus.
- 3) **Maternal factors**—
 - a) Abnormalities of anatomic components of reproductive systems i.e. *garbhāśaya* or *yoniḍoṣa*.
 - b) Hyperactivity or stimulation of myometrium—
 - 1) Reflex stimulation of myometrium in diarrhoea etc. or during suppression of natural urges.
 - 2) Sudden increase in intraabdominal pressure due to trauma, racing, walking, falling, sleeping in abnormal posture etc. described earlier as well as due to straining in diarrhoea etc. causing myometrial hyper-stimulation.
 - 3) Hyper excitability of nerves or abnormalities of *vāta*.

- c) Abnormalities of female hormones—
1. Impregnation in late secretory phase (*pratyahita kala*) or *kāla dosa*. In this condition due to slight withdrawal of hormones endometrium may not allow proper implantation of zygote.
2. Abnormality of hormones or *ātarava dosa*.
- d) Physical trauma—Riding in animals or carriages, trauma, falling etc. described earlier.
- e) Local trauma—during excessive coitus.
- f) Psychogenic factors such as anger, grief, fear, suppression of natural urges, other psychological abnormalities etc.; excessive coitus may also cause some psychological upset leading to abortion.
- g) Nutritional factors:—
- 1) Excessive loss due to diarrhoea, vomiting etc.
- 2) Mal-intake as use of putrified diet, excessive *rūkṣa*, *kāṭu*, *tikta* etc. diet.
- 3) Inadequate intake as suppression of hunger and fasting etc.
- h) Other general diseases of women such as infective or *krmajanya*, fever or *ātapa* and disorders of *vāta* etc. *dosas*.
- i) Age factor or *kāla dosa*—Too young or too old women are more prone for abortion.
- j) Use of abortifacients and other drugs capable of destructing the fetus such as use of *kāṭu*, *tikṣṇa*, *uṣṇa* articles, *kṣāras* and abortifacient drugs.

सम्प्राप्ति (Pathogenesis)

यद्यपि गर्भ-स्राव एवं पात की सम्प्राप्ति का वर्णन आचार्यों ने पृथक् रूप से कहीं नहीं किया, परन्तु मूलागर्भ एवं गर्भ-पात का वर्णन एक साथ ही होने के कारण यह सम्प्राप्ति दोनों की ही मानना चाहिए। महर्षि वाग्भट ने निदान एवं सम्प्राप्ति के पश्चात् 'जो पूर्व वर्णित है' इस वाक्य से इस निदान एवं सम्प्राप्ति को स्पष्ट रूप से गर्भस्राव के लिए भी वर्णित किया है परन्तु सुश्रुत में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है। शरीर स्थान उल्लिखित 'पूर्वोक्त कारण' शब्द कृमिवाताभिघातानि निदान के लिए भी हो सकता है। टीकाकार डल्लण ने व्याख्या में 'इस वर्णन को गर्भस्राव के साथ सम्बद्ध किया है। वर्णित सम्प्राप्ति निम्नांकित है—

वचनों से विमुक्त होकर गर्भ गर्भाशय का अतिक्रमण करके यकृत, प्लीहा एवं आन्त्र के विवर से नीचे आता हुआ कोष्ठ का संक्षेपन करता है। कोष्ठ के संक्षेप से विगुणित हुआ अपान वायु पार्श्व, कुक्षि, बस्तिशर्ष, उदर एवं योनि में शूल, आनाह तथा मूत्रसङ्ग आदि अनेकों व्यापत्तियों को उत्पन्न कर तरण गर्भ को शोणित-स्राव के साथ पीड़ित करता है।

The pathogenesis of obstructed labour and abortion is described together.

The fetus getting detached from its bonds, exceeding normal limits within the uterus, descending downwards from the hollow space between liver, spleen and bowels produces irritation in the abdominal cavity. The *apāna vāyu* getting aggravated due to this irritation causes pain in flanks, *kukṣi* (lower abdomen or uterus), *bastisharṣa* (neck of bladder), abdomen and vagina, along with flatulence or distention of abdomen, retention of urine etc. several other symptoms and troubles the young fetus with bleeding.

१. सु० सं० नि० ८/९ एवं शा० १०/५७ तथा डल्ल० व्याख्या (देखें मूलागर्भान्तर्गत)

२. सु० सं० नि० ८/३; अ० सं० शा० ४/२७ (विस्तृत वर्णन मूलागर्भान्तर्गत देखें)

लक्षण (Clinical features)

सम्प्राप्ति के अन्तर्गत वर्णित शूल, आनाह, मूत्रसङ्ग तथा शोणित-स्रावादि गर्भ-स्राव या पात के लक्षण भी हैं। महर्षि चरक ने केवल 'पुष्प पर्येत' (च० सं० शा० ८/२४) लिखकर ही छोड़ दिया है। अन्य आचार्यों ने निम्न लक्षणों का वर्णन किया है।

Charaka has mentioned only bleeding per-vaginum, however, in other books certain specific clinical features besides above mentioned pain etc. have also been described.

(अ) सामान्य लक्षण (General symptoms)—

तत्र पूर्वोक्तेः कारणैः पतिष्यति गर्भे गर्भाशयकटीवद्भक्षणवसिसूत्राणि रक्तदर्शनं च।

(सु० सं० शा० १०/५७)

तत्र यस्या वसितपार्श्वशोणियोनिमुखेषु शूलं पुष्पदर्शनं वा स्यात् ॥ (अ० सं० शा० ४/३)

पुष्पे दृष्टेऽथवा शूले। (अ० ह० शा० २/१)

जब उपर्युक्त कारणों से गर्भपात होता है तो गर्भाशय, कटि, वक्षण एवं बस्तिप्रदेश में शूल तथा रक्त का दर्शन होता है। टीकाकार डल्लण ने शूलोत्पत्ति गर्भपात-जन्य प्रकुपित वायु के कारण तथा रक्तस्राव आगमर्भ के पात अथवा अर्तव-वह स्रोतस् के मुख के खुल जाने से उत्पन्न अर्तव-स्राव के कारण बताया है।

अष्टांगसंहकार ने लिखा है कि इसको (गर्भपात में स्त्री की) बस्ति, पार्श्व, शोणि एवं योनिमुख में शूल तथा पुष्प-दर्शन (रक्तस्राव) होता है।

अष्टांगहृदयकार ने भी पुष्प-दर्शन अथवा शूल ही लक्षण लिखे हैं।

इसी भाँति आचार्य भवामिश्र, माधव तथा योगरत्नाकर ने भी शूलयुक्त रक्तदर्शन ही लक्षण वर्णन किया है।

When due to earlier mentioned causes abortion starts, there is pain in uterus, sacral and groin region and over the urinary bladder alongwith bleeding. The pain is due to vitiation of *vāyu* and bleeding is due to expulsion of *ātma-garbha* and opening of orifices of *ātarava-vāta-srotasas*.

(आ) प्रसंसमान गर्भ के लक्षण (Symptoms of *prasaṃsamāna garbha* or *slight descent for expulsion*)

प्रसंसमाने सदाहपार्श्वमृदुशूलासुदानाहमूत्रसङ्गः। (सु० सं० शा० १०/५७)

गर्भ के प्रसंसमान अर्थात् पतन के लिए कुछ चलने की अवस्था में पार्श्व एवं पुष्ट में दाह-युक्त शूल, असुदर (अत्यधिक रक्तस्राव), आनाह तथा मूत्रसङ्ग हो जाते हैं।

आचार्य भवामिश्र एवं योगरत्नाकर ने उपर्युक्त वर्णन ही शब्द भेद से किया है।

When the fetus starts its slight descent for expulsion, there is pain alongwith burning

१. गर्भाशयादिशूलानि गर्भपातनिमित्तानिजनितानि; रक्तदर्शनं चामार्गार्थवत् कुच्छुसाध्यम्। यद्यी तु गर्भसंसनेनार्तववहस्रोतो-मुखनिवृत्तेनैववक्षणाद् रक्तदर्शनमित्याह ॥ (सु० सं० शा० १०/५७ की डल्ल० टीका)

२. गर्भे पतति रक्तस्य शूलं दर्शनं भवेत् ॥ (शा० १० चि० ७०/७९; मा० नि० ६४/९ एवं यो० २० स्त्री गर्भो०)।

३. प्रसंसमाने पतनाय किञ्चिच्चलति ...। (सु० सं० शा० १०/५७ की डल्ल० टीका)

४. प्रसंसमाने गर्भे स्यादाहशूलश्च पार्श्वयोः। पृष्ठेऽप्यसुदानाहौ मूत्रसङ्गश्च जायते ॥

(शा० १० चि० ७०/७७ एवं यो० २० स्त्री गर्भो० नि०)

sensation in flanks and back, excessive bleeding, distention of abdomen and retention of urine.

(इ) गर्भ के स्थानान्तर गमन के लक्षण (*Symptoms of shāntānāra gamana or displacement from its original place*)

स्थानात् स्थानं च प्रकामति (चोपकामति-पा० भे०) गर्भे कोष्ठे संरम्भः॥ (सु० सं० शा० १०/५७)

गर्भ के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कोष्ठ (आमपक्वाशयादि^१) में क्षेप उत्पन्न होता है। टीकाकार डल्हाग ने शूलदि लक्षणों का भी समावेश किया है^१।

उपर्युक्त वर्णन को ही शब्दभेद से आचार्य भवामित्र एवं योगरत्नाकर ने भी लिखा है^३।

When the fetus moves from one place to the other there is irritation of the abdominal cavity (stomach and large bowel etc.) and pain.

विमर्श (Comments)

गर्भस्त्राव के सामान्य लक्षणों एवं बाद में वर्णित गर्भरोधक चिकित्सा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सामान्य लक्षण परिहार्य या संभावित गर्भस्त्राव के हैं। प्रसंसमान एवं स्थानान्तर-गमन युक्त गर्भ अपरिहार्यता (असंभाव्यता) के लक्षणों की ओर इशारा करता है। विशेषकर टीकाकार डल्हाग का "पतन की ओर किञ्चित् चलता हुआ गर्भ या प्रसंसमान गर्भ" आदि स्पष्टीकरण।

चरक एवं सुश्रुत संहिता में वर्णित पुत्रन्ती, चरकसंहिता-वर्णित अप्रजा या असुजा एवं काश्यपसंहिता वर्णित जातहृदिपियौ विभिन्न प्रादिक गर्भस्त्राव (हैक्ट्युअल अवॉर्शन) का वर्णन प्रतीत होती है।

अपूर्ण गर्भस्त्राव का स्पष्ट वर्णन आम गर्भ की चिकित्सा के अन्तर्गत किया गया है कि शेष रह जाने पर बारम्बार कह देता है^३।

प्राचीन संहिताओं में अवर्णित गर्भों के गिराने की विधि या प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट द्वारा 'गर्भपतन औषधियों का प्रयोग' आदि का गर्भपतन के कारणों के अन्तर्गत वर्णन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि उस काल में भी गर्भस्त्राव करवाने के लिये औषधियों का प्रयोग होता था। महर्षि सुश्रुत ने मूढगर्भ की चिकित्सा में गर्भपतन कराने का निर्देश दिया है^४। बाद की संहिता योगरत्नाकर^५ ने कतिपय योगों या विधियों का गर्भपतन करवाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है।

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर विभिन्न प्रकार के गर्भस्त्रावों का संहिताओं में वर्णित शब्दों के आधार पर निम्न नामकरण कर सकते हैं।

१. कोष्ठे संरम्भ आमपक्वाशयादि क्षेपः। स्थानं चेति चकोपेण पूर्वोक्ताः शूलद्वयोपि॥ (सु० सं० शा० १०/५७ को डल्हाग टीका)
२. स्थानान्तरगमनान्तरं तस्मिन्मयात्यपि च जायते। आमपक्वाशयादौ तु क्षेपः पूर्वोऽप्युपद्रवाः॥ (पूर्वोऽप्युपद्रवा-पार्श्वशूलद्वयः-पा० प्र० टीका) (भा० प्र० चि० ७०/७८ एवं योगो० २० स्त्री गर्भ से०)
३. अ० सं० शा० ४/१०
४. सू० सं० चि० १५/११, (पृष्ठ २१३)
५. योगो० २० स्त्रीरोगचि०

संहिता-उल्लिखित शब्द

	प्रचलित हिन्दी नामावली
(१) व्यवस्थित या स्थिति योग्य गर्भ	सम्भावित या परिहार्य गर्भपतन
(२) प्रसंसमान गर्भ	असम्भावित या अपरिहार्य गर्भपतन
(३) गर्भक्षेप	अपूर्ण गर्भपतन
(४) अप्रजा या पुत्रन्ती योनि या जातहृदिणी	प्रादिक गर्भपतन
(५) अनवशेष गर्भ	पूर्ण गर्भपतन
(६) गर्भपतन	कृत्रिम गर्भपतन

Considering the clinical features of various conditions mentioned above, the treatment described latter, various *yoniypat* or *jātahārini*, indication for complete evacuation of *āna-garbhā* and use of abortifacient drugs as a cause of abortion, different types of abortions can be summarized in following way.

Words used in classics

	Parallel clinical entity
1. <i>Vyavasthita</i> or <i>sthiti yogyā garbhā</i>	Threatened abortion.
2. <i>Prasamsamānā garbhā</i>	Inevitable abortion.
3. <i>Garbhākṣeṣa</i>	Incomplete abortion.
4. <i>Aprajā</i> and <i>putraghni yoni</i> or <i>jātahārini</i> .	Habitual abortion.
5. <i>Anavāśeṣagarbhā</i>	Complete abortion.
6. <i>Garbhāpātāna</i> .	Induced abortion.

गर्भस्त्राव अथवा गर्भपतन के उपद्रव (Complications of abortion)

गर्भस्त्राव अथवा गर्भपतन के वर्णन के अंतर्गत आचार्यों ने गर्भस्त्राव अथवा पतन से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट विकारों की चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य उल्लेख नहीं किया, परन्तु कुछ व्याधियों के वर्णन के अन्तर्गत गर्भस्त्राव अथवा पतन की कारणभूत माना है यथा-

Specific complications of abortion have not been mentioned in the classics, albeit the treatment of some complications has been prescribed. However, during the course of description of certain disorders abortion has been enlisted as a causative factor such as:-

(अ) शोथ (*Śoṭha* or *oedema/inflammation*)

महर्षि चरक, काश्यप एवं मधुकोष व्याख्याकार ने शोथ के कारणों में गर्भपतन को भी एक कारण माना है^१। शोथ एकाङ्ग अथवा सर्वाङ्ग दोनों ही प्रकार का होता है। गर्भपतनादि के बाद उपसर्ग होकर पैर की रीरा का शोथ हो कर एकाङ्ग शोथ अथवा अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण उत्पन्न पाण्डुजन्म सर्वाङ्ग शोथ हो सकता है।

Due to infection after abortion the phlebitis specially of lower extremities may deve-

१. (अ) निजाः पुनः अन्तः आमगर्भपतनात्। (च० सं० सू० १८/६)
(आ) विषमा प्रसूतिः। (च० सं० चि० १७/६; मा० नि० ३६/५; पा० प्र० चि० ४२/२ एवं योगो० २० शोथो०)
- (इ) विषमा प्रसूतिः अकालगर्भपतनादिका। (च० सं० चि० १२/६ की चक्र० टीका)
- (ई) निःशुलका च। (का० सं० छि० १७/६)
- (उ) विषमा प्रसूतिमगर्भपतनादिका। (मा० नि० ३६/५ की मधुकोष व्याख्या एवं पा० प्र० चि० ४२/२ की टीका)

lop and cause local edema. Generalised edema can develop due to anaemia caused by excessive blood loss during abortion.

(आ) अपतानक (Apātānaka or tetanus)

गर्भपात के कारण उत्पन्न अपतानक को आचार्यों ने असाध्य या दुश्चिकित्स्य माना है^१। टीकाकार डल्हण का मत है कि गर्भपातोत्पन्न अपतानक से पीड़ित रूपा दैव-योग से ही कभी स्वस्थ होती है, यदि स्वस्थ हो भी गई तो वैकल्य अवश्य हो जाता है^२।

गर्भपात विशेषकर कृत्रिम गर्भपात के बाद अपतानक (टेटनेस) होने की सम्भावना होती है जो आज भी यदि असाध्य नहीं तो अत्यधिक दुश्चिकित्स्य अवश्य है।

Apātānaka or convulsions developing after abortion is said to be incurable, however, even if this is cured, it leaves a permanent disability/abnormality.

During abortion specially in induced abortion tetanus is one of the complications which is often fatal.

(इ) अर्श (Piles)

महर्षि चक्र एवं वाग्भट ने आमर्श के श्रेष्ठ होने के कारण अर्श की उत्पत्ति का वर्णन दिया है^३।

Piles are also said to develop due to abortion.

(ई) अन्य (Others)

गर्भ-स्फुरण, वेदना, अदृष्टशोणित वेदना, रक्तपित्तवृत्ति, मूत्रसङ्कट आनाह एवं दाह आदि उपद्रवों की विशिष्ट चिकित्सा का निर्देश है जिसका वर्णन चिकित्सा के अन्तर्गत किया जाएगा।

While describing the management of abortion, treatment of certain complications such as garbha-sphurana (excessive quickening or movements), pain with and without bleeding, excessive bleeding, retention of urine, tympanites and burning sensation etc. has been prescribed.

गर्भावस्था के तीन मास तक पुष्प-दर्शन होने पर गर्भस्थापन में कठिनाता होने का कारण (The causes of incurability of abortion upto third month)

सा चेदपचात् द्वयोस्त्रिषु वा मासेषु पुष्पं पश्येत्तस्या गर्भः स्थायतीति विद्यात्; अजातसाते हि तस्मिन् काले भवति गर्भः ॥ (च० सं० शा० ८/२३)

अपूर्वाग्निमासायास्तु पुष्पदर्शने गर्भः प्रायो न तिष्ठत्यसञ्जातसात्वात् ॥ (अ० सं० शा० ४/७)

असम्पूर्णान्निमासायाः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् ॥ (अ० ह० शा० २/६)

१. (अ) गर्भपातनिमित्तस्य न सिद्धपतानकः । (सु० सं० नि० १/१९; मा० नि० २/२३८)

(आ) गर्भपातसमुत्पन्नः दुश्चिकित्स्यतमो हि सः ॥ (अ० सं० नि० १/५/२३; अ० ह० नि० १/५/२३)

(इ) गर्भपातनिमित्तस्य न सिद्धपतानकः ॥ (मा० प्र० नि० २/४/१९)

२. गर्भपातनिमित्तस्योऽप्यान्तर्लोऽसाध्याः । यदि कश्चिद्दैवयोगात् सिद्धयति तदा वैकल्यं जनयति ॥

(सु० सं० नि० १/५/९ को डल्ह० टीका)

३. (अ) स्त्रीणां चामार्भश्रेष्ठात् ... (च० सं० नि० १/४/९; अ० सं० नि० ७/१०)

(आ) योश्चितं पुनः । आमार्भप्रपतनात् (अ० ह० नि० ७/१४)

उस गर्भिणी स्त्री को अपचार (मिथ्या आहार, विहार) के कारण यदि दूसरे या तीसरे मास में पुष्प-दर्शन (रक्त-स्राव) हो तो वह गर्भ स्थिर नहीं होता क्योंकि उस काल में गर्भ अजातसात होता है।

अष्टांगसंग्रहकार ने भी यही लिखा है कि तीन मास पूर्ण होने के पूर्व पुष्प-दर्शन होने पर असंजातसात होने के कारण प्रायः गर्भ नहीं उठरता। टीकाकार इन्दु का मत है कि यदि सम्यक् चिकित्सा भी की जाय तो भी गर्भ नहीं उठरता। तीन मास के बाद चौथे मास आदि में भी अकटिन्य (अदृढता) होने पर गर्भ नहीं उठरता^१।

अष्टांगहृदयकार ने लिखा है कि तीन मास के पूर्व (गर्भस्राव होने पर) प्रत्याख्यान (निषेध) करके ही चिकित्सा करनी चाहिए। टीकाकार अरुणदत्त ने भी लिखा है कि तीन मास से पूर्व गर्भ अमानव्य एवं असंजातसात होने के कारण बहुल ही कठिनाता से रक्ता है। आमानव्य होने पर सम्पूर्ण तीसरे एवं चौथे मास या इसके बाद संजातसात होने पर भी विरुद्धोपक्रम होने के कारण कठिनाता से ही रक्ता है^२।

महर्षि भेल ने भी शब्द-भेद से यही लिखा है^३।

If due to use of non-congenial diet and mode of life bleeding occurs in second or third month, the fetus is not retained because upto this period it is *asatyaśāstāra* (does not have proper development). and is in *anāwasātha*.

गर्भ में आमानव्य होने पर चिकित्सा में कठिनाता का कारण (The cause of difficulty in the treatment of abortion during association of āma)

यस्याः पुनरामानव्यात् पुष्पदर्शनं स्यात्, प्रायस्तस्यास्तद्गर्भोपघातकरं भवति, विरुद्धोपक्रमत्वात्तयोः ॥

(च० सं० शा० ८/२५)

आमानव्ये चोर्ध्वमपि विरुद्धोपक्रमत्वात् । (अ० सं० शा० ४/८)

प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् । आमानव्ये च ॥ (अ० ह० शा० २/७)

पुनश्च यदि उस स्त्री को (तीसरे मास के उपरान्त भी) आमानव्य (आमजनक कारणों का सम्यक्) के कारण पुष्पदर्शन होता है तो वह विरुद्ध उपक्रम के कारण उस गर्भ का घातक होता है। टीकाकार चक्रवर्णि ने विरुद्धोपक्रम का सम्यक्करण देते हुए लिखा है कि गर्भस्राव में स्तम्भन के लिए शीत, मृदु, मधुर चिकित्सा करनी होती है जो आम के अकिरुद्ध एवं आमजनक है अर्थात् आम की वृद्धि करायी, अन्य आचार्य इसको आतन के लक्षणों (उष्ण आदि आनये लक्षणों) के विपरीत होने से भी विरुद्धोपक्रम मानते हैं^४।

अष्टांगसंग्रहकार ने भी लिखा है कि इसके बाद भी (तीसरे मास के बाद भी) यदि आमानव्य है तो विरुद्धोपक्रम

१. प्रथमान्मासप्रारभ्य मासत्रयं पुष्पदर्शने सम्यक् चिकित्सितोऽपि गर्भः कोष्ठे न तिष्ठत्यसञ्जातसात्वात्, स्वत्येवेत्यर्थः। मासयदूर्ध्वमपि चतुर्थाद्विष्यि मासेष्वकटिन्यात् ॥ (अ० सं० शा० ४/७ को इन्दु टीका)

२. असम्पूर्णान्निमासायाः ... गर्भः प्रायो न तिष्ठति, असंजातसात्वात् । तस्मात् ... प्रत्याख्यानं कृत्वा प्रकर्षणं यत्नेन साधयेत् आमानव्ये च । अमागुणतो रक्तदर्शने सम्पूर्णचिदुत्पत्तिमासाया अपि सञ्जातसातोऽपि गर्भं सति विरुद्धोपक्रमत्वात् प्रत्याख्याय साधनं कारयेत् ॥ (अ० ह० शा० २/६ को अरुण० टीका)

३. यावद् द्वितीये मासे पुष्पं पश्येत् (व/त) स्या गर्भसिद्धतीति विद्यात् । ज्ञाताना (सा) य हि तदा गर्भवत्यो भवति ॥ (अ० सं० शा० ८/५)

४. आमानव्यादिति आमजनकहेतोः सकाशादित्यर्थः । विरुद्धोपक्रमत्वादिति गर्भस्रावे हि स्तम्भनं कर्तव्यं तच्च शीतं मृदुमधुरं च तत्त्वामिदिरुद्धम्, आमजनकत्वात् इति विरुद्धोपक्रमता । अन्यो वेति अतर्वलक्षणव्यतिरिक्तः ।

(च० सं० शा० ८/२५ को चक्र० टीका)

होने से गर्भ नहीं ठहरता अन्यथा पुष्प-दर्शन होने पर भी गर्भ आसानी से ठहर जाता है^१ ।

अष्टांगसंग्रहकार ने भी लिखा है कि आमाश्व्य होने पर प्रत्याख्याय कहकर ही चिकित्सा करें ।

टीकाकार डल्हण ने रक्तगुल्म के निदान की व्याख्या करते हुए गर्भ में अमला की मर्यादा छोटे मास तक मानी है^१ ।

Upto third month or even afterwards when the fetus has association of *āma* and bleeding starts, then usually it kills the fetus due to opposite character of treatment i.e. for stopping the bleeding and retaining the fetus *śīta* (cold), *mṛdu* (soft) and *madhura* (sweet) drugs had to be prescribed which will increase *āma* due to similarity in properties, besides these drugs are also opposite to qualities of *ārava* which is hot and *āgneya* in character.

गर्भस्त्राव चिकित्सा (Treatment of abortion)

(१) आम गर्भस्त्राव चिकित्सा (Treatment of abortion of āma-*gṛathā*)

(अ) पात होने के पूर्व चिकित्सा (Treatment before its expulsion)

(१) रक्त एवं शीत द्रव्यों का प्रयोग करना श्रेयस्कर्म है^१ ।

(२) उपवास करने के पश्चात् दुर्गलण, अमृत, उशीर, पर्पटक, घन, चन्दन, अतिविषा, बला, कटुवर्ग तथा धान्यक का क्वाथ बनाकर पीने को दें^{१,४} ।

(३) तुण-धान्य^१, शालि या षष्टिक को पेया या^४ भोजन^{३,४} के रूप में दें^{३,४} ।

(४) मुद्गादि से बने यूस को पीने से आम के विजित हो जाने पर या शीत हो जाने पर स्निग्ध, शीत या स्निग्ध क्रिया पूर्वक करें^{३,४} ।

i) Use of dry and cold substances is beneficial.

ii) After observing fast, the decoction made with *durālābhā*, *amṛta*, *uśīra*, *parpatāka*, *ghana*, *candana*, *atviṣā*, *balā*, *kaṭwāṅga* and *dhānya* should be prescribed.

iii) *Tṛya dhānya* and *śālī* or *ṣaṣṭika* rice should be used in the form of gruel or solid diet.

iv) Soup prepared with *mudga* etc. should be prescribed in diet for digestion of *āma*. Once the state of *āma* is corrected, unctuous alongwith cold or only unctuous measures should be used.

१. यत्र चतुर्धादिद्विषि मासेज्जामान्वयो नास्ति तत्र पुष्यदर्शनेऽपि गर्भो विषादिभिरु सुशक्यते ॥ (अ० सं० शा० ४/८ को इन्दु टीका)

२. आमागर्भं, षण्मासं यावत्॥ (सु० सं० उ० ४२/२३ की डल्ह० टीका)

३. तत्र रक्तशीतानि प्रयुञ्जीत ॥ ८ ॥

तद्वशा-श्रापुवासं तथा दुर्गलभाऽमृतोशीरपट्टनचन्दनातिविषाबलाकटुवर्गधान्यक्वाथपानं तुणधान्यशालिषष्टिकपेयमशनं च मुद्गादिपूषैर्जीने त्वाने स्निग्धशीतानि पूर्ववत् ॥ १ ॥ (अ० सं० शा० ४/८, ९)

४. आमाश्व्येवैतदेष्टं शीतं रक्तोपसंहितम् । उपवासो घनोशीरुद्ध्यारुणान्काः ॥ ७ ॥

दुर्गलभापट्टकचन्दनातिविषाबलाः । क्वथिताः सन्ति ते पानं तुणधान्यानि भोजनम् ॥ ८ ॥

मुद्गादिपूषैरपे तु जिते स्निग्धादि पूर्ववत् ॥ ९ ॥ (अ० ह० शा० २)

(आ) पात हो जाने के बाद चिकित्सा (Treatment after its expulsion)

पेयादि प्रयोग (Oral use of potion etc)

(१) गर्भ के पतित हो जाने के बाद गर्भकोष्ठ की शुद्धि तथा वेदना के विस्मरण के लिए सामर्थ्यानुसार मद्य का पान करायें^{१,३} ।

(२) मद्यपान के पश्चात् लघुपञ्चमूल से सिद्ध रूक्ष (स्नेह विरहित) पेया पीने को दें^१ ।

(३) अमद्यपि अर्थात् मद्यपान न करने वाली स्त्री को तिल एवं उद्दालक से बनाई, पाचन द्रव्यों से युक्त, लवण तथा स्नेह से विरहित यवागू^{१,३} अथवा तिल, उद्दालक (वनकोदर) या तण्डुल से, विट्चपंचक (बृहत् पंचमूल) के क्वाथ में बनी हुई, पंचकोल के कल्क से साधित पेया^१ आदि का क्रम से उतने दिन तक प्रयोग करें जितने मास का गर्भपात हुआ हो^{१,३} अर्थात् यदि दो मास का गर्भपात है तो दो दिन यह पेयादि क्रम दें ।

महर्षि सुश्रुत ने मद्य का विषयन नहीं दिया एवं लिखा है कि गर्भ के अतीत (पतित) होने पर पाचनीय द्रव्यों से संस्कृत, लवण एवं स्नेह से विरहित उद्दालक आदि की यवागू जितने मास का गर्भ है उतने दिन तक पीने को दें । टीकाकार डल्हण ने वाग्भटानुसार लघन-पूर्वक इस यवागू के प्रयोग का विषयन बताया है तथा आम-गर्भ-चिकित्सार्ष अष्टाङ्गहृदय द्वारा उल्लिखित (पृष्ठ ३३४) औषधियों के प्रयोग का भी वर्णन किया है^१ ।

महर्षि सुश्रुत ने उपर्युक्त चिकित्सा गर्भपात होने के बाद की लिखी है इनमें आम शब्द का प्रयोग नहीं किया परन्तु टीकाकार डल्हण ने 'आमाश्व्ये' शब्द लिखा है । चिकित्सा-सूत्र का सामंजस्य होने के कारण इसका यहाँ वर्णन किया गया है^१ ।

(४) लघु, स्नेह एवं लवण विरहित दीपनीय द्रव्य युक्त पेया हितकारी होती है^१ ।

(५) न्यून दिन का या कम दिन का गर्भपात होने पर वेणुग्रन्थि, कुलस्थ एवं हृदिद्रा का क्वाथ पीने को देना चाहिए^४ ।

(६) महर्षि शार्ङ्गधर ने अकालप्रसूता को प्रसव (गर्भस्त्राव या गर्भपात) हो जाने के पश्चात् स्वेदन देने का निर्देश दिया है^१ ।

i) After expulsion of products of conception, for cleansing or complete evacuation of uterus and relief of pain, wine should be given considering her strength.

ii) After use of this wine she should be given a fat-free potion medicated with drugs of *laghupāñcamūla*.

१. आमागर्भं तु पतिते मद्यानामन्यतमं सामर्थ्यतः पायवेदागर्भकोष्ठविशुद्धयर्थमतिविस्मरणार्थं च । अमद्यपि पाचनीयद्रव्योपहितोष्णः स्नेहेलवणवर्जोऽपि सति तिलाभिरुद्दालकादिपत्रागूभिरुपचरेद्यावन्तो मासस्त्रावन्त्यहनीति ॥ (अ० सं० शा० ४/१०)

२. गर्भं निपतिते तीक्ष्णं मद्यं सामर्थ्यतः पिबेत् ॥ ९ ॥

गर्भकोष्ठविशुद्धयर्थमतिविस्मरणाय च । लघुना पञ्चमूलेन रूक्षां पेयां ततः पिबेत् ॥ १० ॥

पेयाममद्यपि कल्के साधिता पाञ्चकौलिके । विट्चपंचकपञ्चकवशात् तिलोद्दालकतण्डुले ॥ ११ ॥

मासतुल्यदिनान्यत्र पेयादिः पतिते क्रमः । लघुस्नेहेलवणो दीपनीययुतो हितः ॥ १२ ॥ (अ० ह० शा० २)

३. अतीते लवणस्नेहेनान्यभिर्द्रव्यागूभिरुद्दालकादीनां पाचनीयोपसंस्कृताभिरुपक्रमेत यावन्तो मासा गर्भस्य तावन्त्यहनि ॥ ५ ॥ (अतीते पतिते इत्यर्थः । आमाश्व्ये च तदेष्टं शीतं तुणधान्यादिभोजनम् : (अ० ह० शा० २/७, ८ सदृश ही पृष्ठ ३३४) (सु० शा० सं० १०/५७ एवं डल्ह० टीका)

४. वेणुग्रन्थिकुलस्थानां हरिद्रावर्जितं श्रूयम् । देवं न्यूनादिने पाते गर्भपीनां भिषक्चैः ॥ (यो २० स्त्रीपरीय वि०)

५. पञ्चालस्वेद्या प्रजाताऽकाले वा ... । (शा० सं० उ० २/८)

iii) The woman not inclined to use wine should be prescribed either fat and salt free gruel made with *tila* and *uddālaka*, mixed with digestive drugs, or a beverage made of *tila*, *uddālaka* or rice prepared with decoction of *biḥṭṭapāñcanā* and medicated with paste of *pañcakola*. The duration of use of these dietetics should correspond to the duration of pregnancy or in other words if the pregnancy was of two month this dietetic regimen should be given only for two days.

iv) A fat and salt free *laghu* (light) potion prepared with appetizing drugs is beneficial.

v) In cases of abortions of very short duration the decoction of *venugrahaṇi*, *kalathia* and *haridrā* should be prescribed.

vi) Use of sudation is beneficial.

पेयादि प्रयोग की उपादेयता एवं प्रयोग-सीमा (Benefits and duration of use of these potions)

(अ) उपादेयता (Benefits)

दोषघातुपरिवर्तदोषाद्यै विधिरित्यम् ॥ (अ० ह० शा० २/१३)

दोष एवं घातुओं के परिवर्तित (आमोत्पन्न कलेद) के शोषण के लिए यह विधि वर्णित है।

Above mentioned liquids are prescribed for desiccation of moisture produced by *āma*.

(आ) प्रयोग-सीमा (Duration of use)

ततः प्रीणनैर्लानुक्षिभिरन्यैराहारैरादोषाणाकुलेदशुद्धैः ॥ (अ० सं० शा० ४/१०)

जब तक दोषों (विकृत दोषों) तथा घातुओं के कलेद (आम जनित कलेद) की शुद्धि न हो जाय तब तक प्रीणन (संतुष्टि या तृप्तिदायक या शामक) द्रव्यों द्वारा संस्कृत, कल की रक्षा करने वाला, स्नेह विरहित आहार देना चाहिए।

Till the moisture of *dosas* and *dhatūs* produced by *āma* is not cleared, fat-free diet mixed with gratifying substances capable of protecting her strength should be given.

आम गर्भ के शोष रह जाने पर उपद्रव एवं चिकित्सा (Complications of incomplete expulsion of āma garbha and its treatment)

आमामशेषेण हि पुनः पुनः शूलमनुबन्धेत । तस्मात्तीक्ष्णैरनवशेषघ्नप्राचेत् ॥

(अ० सं० शा० ४/१०)

आमामर्ष शेष रह जाने पर पुनः पुनः शूल (कष्ट) उत्पन्न करता है अतः तीक्ष्णादि द्रव्यों द्वारा अनवशेष (अर्थात् सम्पूर्ण बाहर निकल जाने की) स्थिति तक उपचार करें।

Incompletely expelled *āma garbha* troubles the woman repeatedly, hence it should be treated by pungent drugs till its complete expulsion.

गर्भपात के बाद बसित एवं उदरशूल की चिकित्सा (Treatment of pain in abdomen and bladder region persisting after abortion)

महर्षि सुश्रुत ने अतीत (पतित) गर्भ की चिकित्सा के पश्चात् बसित एवं उदरशूल की चिकित्सा का वर्णन किया है, जिसका तात्पर्य सम्भवतः गर्भपात के पश्चात् भी बसित या उदरशूल होते रहने की चिकित्सा का वर्णन है।

गर्भ-व्यापद

बसित एवं उदरशूल में दीपनीय द्रव्यों से युक्त पुराने गुड़ का प्रयोग अथवा अरिष्ट (अपयारिष्टादि) का पान करण^१।
For pain in abdomen and bladder region old jaggery mixed with appetizing drugs or *abhyatāṅṣṭa* etc. *ariṣṭas* should be prescribed.

आमगर्भ के पूर्णरूपेण निकल जाने पर चिकित्सा (Treatment after complete expulsion of āmagarbha)

आमगर्भ के पूर्णरूपेण निकल जाने के पश्चात् स्नेहपान, बसित एवं दीपनीय, पाचनीय, जीवनीय, वृद्धणीय, मयुर तथा जलहार आहार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए^२।

महर्षि चरक ने अत्युत्तम गर्भा के वर्णन के पश्चात् गर्भ-शल्पोद्धारण की चिकित्सा वर्णन की है तथा पश्चात् कर्म में व्यापगत गर्भशल्पा एवं आमगर्भा शब्दों का प्रयोग किया है अर्थात् वह चिकित्सा यहाँ भी करनी चाहिए^३।

After complete expulsion of *āma garbha* the woman should be prescribed *snehapāna* (oral use of oil or *ghrita*), enemas and diet consisting of appetizing, digestive, *jīvanīya* (life prolonging), anabolic, sweet and *vāta* suppressing articles.

Treatment prescribed after extraction of intra-uterine dead fetus can also be used.

अपप्रसूता या अकाल प्रसूता को स्नेहन निषेध एवं स्नेह देने का परिणाम (Contraindications for use of oleation and complication of its use by woman having abortion)

आचार्यों ने अपप्रसूता (सुतागर्भा-अरुणदत्त) या अकाल प्रसूता (अकाल अर्थात् समय से पूर्व प्रसूता अर्थात् गर्भस्राव वाली स्त्री) अर्थ लिया जा सकता है। को स्नेह पान कराने का निषेध किया^४ है। महर्षि सुश्रुत ने स्नेहपान के परिणामों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अकाल प्रसूता को स्नेहपान करने से गर्भगण्ड के अन्दर रक्त, कलेद एवं मल आदि दोष अवशेष रह जाते हैं। टीकाकार डल्हण का मत है कि ये रक्तादि अवशिष्ट दोष स्नेह से प्रकुपित होकर असाध्य रोग उत्पन्न कर देते हैं। अतः अकाल प्रसूता को स्नेहपान न कराकर पाचन एवं रूक्ष औषधियों का प्रयोग दस दिन तक करना चाहिए^५।

Snehana (oleation) should not be given to a woman who had aborted. If oleation is used then blood, *kleda* (moisture) and *mala* (impurities) are retained in the uterus and produce various incurable disorders, hence the woman should be given *pācana* (digestive) and *rūkṣa* (dry) drugs/substances for ten days, later on methodical use of oleation can be done.

१. बसुदरश्लेषे पुराणगुडं दीपनीयसंस्कृतं पायदेरिष्टं वा (अरिष्टमपयारिष्टादिकम् - डल्हण) (सु० सं० शा० १०/५७)

२. (अ) ततः परं स्नेहपानैर्बसितभिगाहारैश्च दीपनीयपाचनीयजीवनीयवृद्धणीयमयुरजालहारैरिति ॥ (अ० सं० शा० ४/१०)

(आ) स्नेहपानस्तथाचोर्ध्वं बल्यदीपनीयजानाः ॥ (अ० ह० शा० २/१३)

३. च० सं० शा० ८/३१ (अथवा ८ में वर्णित)

४. (अ) अकाले च प्रसूता स्त्री स्नेहपानं विवर्जयेत् ॥ (सु० सं० चि० ३१/८८)

(आ) स्नेहान् न अपप्रसूता ...। (अ० सं० सू० १५/१०, ११; अ० ह० सू० १८/६, ८; अपप्रसूता सुतागर्भा-अरुणदत्त टीका)

(३) अकाल प्रसूतान्तरं। (शा० सं० उ० १/२६ एवं पा० प्र० पूर्व० २-४/२८)

५. गर्भाशयेऽवशेषाः स्यू रक्तकलेदमलास्ततः । स्नेहं जह्यान्निषेधेत पाचनं रूक्षमेव च ॥

दशराजः ततः स्नेहं यथावद्व्याचारेत् ॥

(अकाले प्रसूताया गर्भाशये अवशेषा रक्तकलेदमलाः स्नेहकोपिता असाध्य रोगं कुर्वन्-डल्हण) (सु० सं० चि० ३१/५०, ५१)

(२) व्यवस्थित होने योग्य या परिहार्य गर्भस्राव की चिकित्सा (Treatment of threatened abortion)

यद्यपि आचार्यों ने चिकित्सोपेक्ष में कहीं भी ऐसा कोई स्पष्ट शब्द प्रयुक्त नहीं किया जिसके आधार पर निम्नलिखित वर्णन को व्यवस्थित होने योग्य या परिहार्य गर्भस्राव की चिकित्सा के अन्तर्गत रखा जा सके, फिर भी योगों में मधु, शीत एवं मृदु आदि द्रव्यों के प्राधान्य के आधार पर तथा महर्षि चरक के 'गर्भस्थान विधिमुपदेस्यमः' तथा "तथाऽस्यागर्भस्थिति-च० शा० ८/२७" वाक्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्नोक्त वर्णन गर्भ को व्यवस्थित (रोकने) करने की चिकित्सा का है। यह सभी चिकित्सा पुष्प-दर्शन के बाद शीघ्र ही प्रारम्भ कर देने चाहिए।

Caraka says that the method for stability of fetus is being told, by this her abortion is prevented.

The treatment should be started immediately after evidence of bleeding per vaginum.

चिकित्सा के समय स्त्री की शय्या एवं उसकी स्थिति (Position of woman during treatment)

उसे (पुष्प-दर्शन होने वाली गर्भवती स्त्री को तत्काल ही) मृदु, सुवक्त्रारी एवं शीतल विस्तर पर सिर को थोड़ा सा नीचे की ओर करके शयन करने का आदेश दें।

The woman should be made to sleep on a soft, comfortable and cool bed having head end lower than the foot end.

सामान्य चिकित्सा-सिद्धान्त (Principles of treatment)

शीतल परिरक्षक, अवगाह, प्रदेह एवं जीवनीय औषधियों से श्रुत क्षीर-पान आदि के द्वारा चिकित्सा करें। महर्षि भेल ने दोषानुसार चिकित्सा करने का एवं वायु-पद से शोषन-विरहित रक्तपित्त की क्रिया करने का निर्देश दिया है। इसमें दुग्ध-पान पथ्य एवं उष्णोदकानुपान निषिद्ध है।

She should be treated with cold bath, pourings, irrigations, tub-bath, immersions, unctions, and drinking of milk boiled with *jivanyu* group of drugs. The treatment should also be prescribed according to dominance of *dosha*, treatment prescribed for *raktapitta* (bleeding diathesis) except purifying measures can also be used. Milk is beneficial and hot water is contraindicated.

प्रसंसमान एवं स्थानान्तर गमित गर्भ की चिकित्सा (Treatment of prasangamāna garbha or śhātāntara garbha)

तत्र निगम्यशीताः क्रियाः ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)

१. तस्या गर्भस्थानविधिमुपदेस्यमः। पुष्पदर्शनादेवैतं कृणुत्। (च० सं० शा० ८/२४)
२. शयनं तावन्मृदुसुखशिशिरासतपसंस्तीर्णमिषदवनतशिरस्कं प्रतिनयस्वति ॥ (च० सं० शा० ८/२४)
- (आ) तां मृदुसुखशिशिरासतपस्यनस्यामोषदवनतशिरसंउपाचरेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/३)
३. (अ) तत्रशीतैः परिरक्षकवाहप्रदेहादिभरणचरैःजीवनीयश्रुतशीतानैश्च ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)
- (आ) शीतप्रदेह परिरक्षकादिभरणचरैः ॥ (अ० सं० शा० ४/३)
- (इ) पुष्पं दृष्टेऽथवा शूलं बाधान्तः स्निगधशीतलम् ॥ (अ० ह० शा० २/९) ..
४. तस्मादन्तांश्चिकित्सतु दोषान् पुत्रचिकीर्षया ॥ (पे० सं० शा० ३/१५)
५. (अ) रक्तपित्तक्रियाश्च शोषनवर्त्याः प्रयुञ्जीत ॥ (अ० सं० शा० ४/५)
- (आ) शुद्धिवर्त्त चाऽऽस्तोक्तमाचरेत् ॥ (अ० ह० शा० २/६)
६. तत्र सर्वमेव क्षीरं योनिरोगगर्भस्राव हृत् ॥ (सु० सं० शा० ४५/४९)
७. का० सं० सू० २२/१४ (पृष्ठ २८६)

गर्भ-व्यापद

इसमें निगम्य एवं शीत क्रिया करनी चाहिए।

भावप्रकाश तथा योगरत्नाकरकार ने लिखा है कि प्रचलित गर्भ एवं कुक्षि-रज्जा में भी ह्रीनेर, अतिविषा, मुस्ता, मोच तथा शक का क्वाथ नानाकर देना चाहिए।

Uctuous and cold things should be prescribed. In this condition and also in pain in uterus the decoction of *hrībēra*, *divisā*, *masū*, *mocharasa* and *śakra* should be given.

स्थित होने योग्य या परिहार्य गर्भस्राव में अन्य औषधि-प्रयोग (Other medicines for threatened abortion)

(अ) बाह्य-प्रयोग (Medicines for external use)

- (१) मधुपट्टी एवं सर्पिं से आल्कावित अति शीतल जल में रखे हुए पिचु को उपरस के समीप (यौनि में) धारण कराये।
- (२) शतधौत^{३,४} या सहस्रधौत^{३,४} घृत को नाभि के नीचे के (उदर) भाग में चारों ओर प्रदेह (लेप) करें^{३,४}।
- (३) अच्छी प्रकार शीतल किए हुए गाय के दुग्ध या मधुपट्टी के क्वाथ या न्यग्रोधादिगण के कषाय से नाभि के नीचे परिरचन^{३,४} करें।
- (४) अच्छी प्रकार से शीतल जल से अवगाहन कराये^{३,४}।
- (५) कषाय एवं क्षीरिवृक्षों के (त्वक् या पत्र के क्वाथ या) स्वरस में कपड़ा (पिचु) भिगो कर (यौनि में) ग्रहण कराये।
- (६) न्यग्रोधादि (गण के वृक्षों के) शृंग से साधित क्षीरसर्पिं (क्षीरदूधत घृत) अथवा क्षीर या सर्पिं का पिचु धारण कराये^{३,४}।
- (७) मधुपट्टी से सिद्ध अच्छी प्रकार से शीतल घृत में पिचु भिगाकर यौनि के समीप स्थापन करें^३।
- (८) न्यग्रोधादिगण से सिद्ध तैल का पिचु यौनि में धारण करें^३।
- (९) सेव्य, अम्भोज, हिम, क्षीरिवृक्ष के कल्कल के कल्क से लेपित करके अत्यधिक अर्द्र या गीले पिचु एवं नक्तक (चैलखण्ड या कपड़े के टुकड़ों) को यौनि या बस्ति में (यौनि के अन्दर एवं बस्तिप्रदेश के ऊपर) धारण करें^३।
- (१०) कुमारी लड़कियों के द्वारा कते हुए गर्भिणी के शरीर के बराबर लम्बे सूत्र में कंकली की जड़ को बाँधकर कमर में धारण करने से गर्भपात का निवारण होता है^१।

१. ह्रीवेरातिक्वामुस्तमोयश्चक्रेऽभृत् जलम् । दद्याद् गर्भे प्रचलिते प्रदेः कुक्षिरज्ज्यापि ॥ ९॥

(भा० प्र० चि० ७०/६४; यो० १० स्त्री गर्भ तौ चि०)

२. ततो यष्टिमधुनृक्सर्पिर्घ्वा परमशिशिरावरिणि सींश्चताप्यां पिचुभाल्वाव्योपस्थसमीपे स्थापयेत्स्याः, तथा शतधौतसहस्रधौताप्यां सर्पिर्घ्वाभ्यधोनाभौः सर्वतः प्रदिह्यात्, सर्वतश्च गन्धेन चैतं पयसा सुशीतेन मधुकाण्डना वा न्यग्रोधादिकषायेण वा परिरचयेदधोनाभौः उदकं वा सुशीतमवगाहयेत्, क्षीरिणां कषायदुग्धगणां च स्वरसपरीपेतानि चेतानि ग्राहयेत् ।
३. न्यग्रोधादिशुद्धिद्योर्वा क्षीरसर्पिणोः पिचुं ग्राहयेत् ॥ (च० सं० शा० ८/२४)
४. तद्वधः सहस्रधौतेन सर्पिर्घ्वाऽधोनाभौः सर्वतः प्रदिह्यात् । मधुकाण्डनापि सुशीतेन पिचुभाल्वाव्यो योनिसमीपे स्थापयेत् । गन्धेन पयसा मधुकाण्डना न्यग्रोधादिकषायेण वा परिरचयेत् । परीपेतस्वरसादि च तैलानि यौनी निधापयेत् ॥ तच्चुङ्गसिद्धस्य वा क्षीरसर्पिणः पिचुम् ॥ (क्षीरेव प्रमथ्य सम्मालितं सर्पिः क्षीरघृतम्-इदु टीका) (अ० सं० शा० ४/४)
५. सेव्याऽम्भोजक्षीरिवृक्षकल्कलकाण्डज्यालेपितान् । धारयेद्यौनिबस्तिव्यामाद्रान् पिचुनक्तकान् ॥ १॥
६. शतधौतघृतात् स्त्री तदपस्थव्याहयेत् ॥ (अ० ह० शा० २/२ व ३)
७. कङ्कलीमूलमाबद्धं कुमारीसूत्रकैः समैः । कटिदेशे नितान्धन्या गर्भपातं निवारयेत् ॥ (यो० १० स्त्रीगर्भतौ चिकित्सा)

- (११) न्यग्रोधादि गण की औषधियों के स्वरस में मिर्मांश हुआ कस योगि में धारण^१ करें।
 (१२) लक्ष्मिद तैल का गर्भिणी को बारम्बार अभ्यङ्ग करने से गर्भ पुष्ट होता है^२। लक्ष्मिद तैल निर्माणविधि निम्नीकृत है^३:-

एक आढक लक्षा लेकर चार आढक जल के साथ क्वाथ बनावें। चतुर्थीय शेष रहने पर इसे छान लें, अब इसमें एक प्रस्थ तैल, गोदधि का एक आढक मसु तथा शतपुष्प, अथवांश, हरिद्रा, देवदार, कुटकी, रेणुका, मूत्रा, कुष्ठ, मधुयष्टी, चन्दन, मुस्तक एवं रास्ना का एक-एक कर्ष चूर्ण डाल कर मसु अग्नि में भलीभाँति पकावें। इस तैल के अभ्यङ्ग से सभी विषम चक्र शांत होते हैं। गर्भिणी को बारम्बार अभ्यङ्ग करने से उसका गर्भ पुष्ट होता है।

- A tampon soaked with paste of *madhuyasfi* and *ghrita* then kept in extremely cold water should be placed in vagina.
- Hundred or thousand times washed *ghrita* should be anointed over infraumbilical region.
- Properly cooled cow's milk or decoction of *madhuyasfi* or decoction of the drugs of *nyagrodhadi* group should be poured over infraumbilical region.
- Tub-bath with sufficiently cooled water should be given.
- A piece of cloth soaked with the juice or decoction of leaves or stem bark of latex yielding trees or plants having *karaya* (astringent) property should be placed in vagina.
- A tampon soaked with *ghrita* extracted from milk or *ghrita* or milk medicated with leaf-buds of *nyagrodhadi* group of drugs should be used.
- A tampon soaked with nicely cooled *ghrita* medicated with *madhuyasfi* should be placed in vagina.
- A tampon soaked with oil prepared with *nyagrodhadi* group of drugs should be placed in vagina.
- Over moistened tampon or piece of cloth anointed with paste of *sevyu*, *ambhoja*, *hima* and stem bark of latex yielding plants should be placed in vagina or over the urinary bladder region.
- The root of *kanikari* knotted with a thread, spined by a young virgin, having length identical to the height of the pregnant woman should be tied in her waist. This prevents abortion.
- A cloth soaked with the juice of *nyagrodhadi* group of drugs should be placed in vagina.

१. न्यग्रोधादिस्वरसमयितं वा कस्रावयवं योन्मां धारयेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)
 (महर्षि सुश्रुत ने यह चिकित्सा अत्यधिक रक्तसाव होने पर बताई है)।

२. लक्ष्मिदं क्वाथयित्वा जलस्य चतुर्दशैः। चतुर्थांशं शृतं नीत्वा तैलप्रस्थं विनिक्षिपेत् ॥ १३॥
 मस्रकढकं च गोदध्नस्तत्रैव विनियोजयेत्। शतपुष्पमथवांश्या हरिद्रा देवदार च ॥ १४॥
 कुटकी रेणुका मूत्रा कुष्ठं च मधुयष्टिकाम्। चन्दनं मुस्तकं रास्ना पृथक्प्रमाणतः ॥ १५॥
 चूर्णयेत्तत्र निक्षिप्य साधयेन्मुद्रादिना। अस्याभ्यङ्गात्तशाम्यति सर्वेऽपि विषमज्याः ॥ १६॥
 पुष्टगर्भा भवेदस्य गर्भिण्यभ्यङ्गो पृथग् ॥ १८॥ (शा० सं० मध्य ख० ९)

- xii) Repeated massage of *lākṣādi* oil to the pregnant woman is a good nourishing agent to her fetus. The method of preparation of *lākṣādi* oil is as follows.

One *ādḥaka lākṣā* should be boiled with four *ādḥika* water, when one-fourth remains it should be strained. Now in this one *prashā* oil, one *ādḥaka masu* (water of curd) made with cow's milk, powdered *śatapuspā*, *asvaganthā*, *haridrā*, *devadaru*, *kuṭāḥ*, *reṇukā*, *mūtrā*, *kuṣṭha*, *madhuyasfi*, *candana*, *mustaka* and *rāsna* each one *karṣa* should be mixed and oil prepared over low fire. Massage of this oil cures all types of *vīṣamajwara*, (intermittent fevers). Repeated massage of this to a pregnant woman makes her fetus well nourished and strong.

(अ) आभ्यन्तर प्रयोग (Medicines for oral use)

- टीकाकार चक्रपाणि एवं इन्द्र ने सभी गर्भस्थापन औषधियों का प्रयोग गर्भस्त्राव एवं फाल की चिकित्सा में करने का निर्देश किया है^१।
- पुंसवन कर्मांतर्गत वर्णित लक्ष्मण के मुख या नासा से प्रयोग की टीकाकार इच्छण, इन्द्र एवं अरुण दत्त ने गर्भस्थापक भी बताया है^२।
- न्यग्रोधादि शुद्ध से साधित क्षीरसर्पि को एक अक्ष की मात्रा में खाने को दें^{३,४}।
- केवल क्षीरसर्पि खाने को दें^५।
- पद्म, उत्पल, कुमुद के केशरों का कल्क मधु एवं शर्करा के साथ^६ या सिला, मधु एवं क्षीरघृत के साथ^७ चाटने को दें।
- शृंगारक, कसेरू एवं पुष्करजीव खाने को दें^८।
- गन्धप्रियंगु, असितोत्पल (नीलकमल), शालुक (कमल की जड़), उदुम्बर-शलाटु (उदुम्बर का कच्चा फल) एवं न्यग्रोध-शुद्ध को अजा-क्षीर के साथ पीने को दें^{३,४,५}।
- मृदु (खूब मुलायम), सुरभि द्रव्यों से युग्मिधत्, शीतल रक्त शाली के भात को बला, अतिबला, शालि, षष्टिक एवं इक्षु सभी की मूल एवं काकोली से साधित दुग्ध में शर्करा एवं मधु^९ मिश्रित कर अथवा शीत वीर्य जांगल पशु-पक्षियों के मांसरस के साथ खाने को दें^{६,८}।
- लाव, कर्पिजल (गोरेया), कुरंग (पुंग), शाम्बर (बारहसिंघा), शयक, हरिण, कालपुच्छक (काली पुँछ वाला हिरण) के (मांस) रस को घृत से सुसंस्कृत करके गर्भिणी को सुखकारी, शीतल, वायु-युक्त स्थान में बैठकर (रक्तशाली के ओदन के साथ) खाने को दें^३।
- धातकी, गैरिक, सर्जर्स एवं रसंजन के चूर्ण को मधु के साथ चाटने को दें^४।
- न्यग्रोधादि गण के वृक्षों की त्वचा या कोमल पत्तों के कल्क को अकेला ही^५ या दुग्ध के साथ पीने को दें^४।
- जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर^६ अथवा क्षीर में शालि-पिष्टी मिलकर दें^४।
- अत्यधिक रक्तस्त्राव होने पर कोष्ठागारिका के घर की मिट्टी, समंगा (लज्जालु), धातकी-पुष्प, नवमासिका (वनमस्त्रिका के पुष्प या नवमृत्तिका), गैरिक, सर्जर्स, रसंजन में से यथा उपलब्ध द्रव्यों के चूर्ण को मधु के साथ चाटे^{४,७,८}।

नोट- सन्दर्भ पृष्ठ ३४२-३४३ में देखें

- (१४) उत्पलादि गण या कशेरु, शृंगाटक एवं शालूक^{१४} या उत्पल का कल्क^{१५} शृत (उवाले हुए) दुग्ध के साथ पीने को दें^{१६} ।
- (१५) शालि-पिष्ट (पीसे हुए शाली धान्य की पिष्ट) को शर्करा एवं मधु मिलाकर मधुर किए हुए उदुम्बर फल या उदक कन्द (जल में उत्पन्न होने वाले कन्द यथा कमल, कुमुदिनी आदि के कन्द) के क्वाथ के साथ पीने को दें^{१७} ।
- (१६) शरा, एण (विशिष्ट मृग) एवं हरिण के रक्त को मधु मिश्रित कर पीने को दें^{१८} ।
- (१७) वृद्ध, विदारि एवं जीवन्ती (चूर्ण) दुग्ध के साथ पीने को दें^{१९} ।
- (१८) नीलतल, सिला (दूर्वा), पक्वलोह (कुम्हार के यहाँ की पकी मिट्टी) एवं चन्दनादि गण की औषधियों को (चूर्ण को) ताड़ुलायु या वासा के स्मरस के साथ रसांजन मिलाकर प्रयोग करावें^{२०} ।
- (१९) कसेरु, मृणाल, शृंगाटक, काशमरी (गम्पारी), परुषक, द्राक्षा, सारिवा, प्रणोण्डरीक (पुण्डरीक या सन्दिप इत्यम्), अनन्ता (दूर्वा), उत्पल, कदम्ब बीज के क्वाथ को शर्करा एवं मधु के साथ पीने को दें^{२१} ।
- (२०) कान्ता (प्रियांगु), अब्ज, शालूक एवं उदुम्बर के कच्चे फल (के कल्क) से युक्त क्षीर पान करें^{२२} ।
- (२१) लज्जालु, धातकीपुष्प, उत्पल एवं तोष को (चूर्ण को) मधु के साथ जलस्थ (जल में बैठाती गई हुई) स्त्री को पिलाने से गर्भपात का निवारण होता है^{२३} ।
- (२२) कुलालकामृतिका (कुम्हार के हाथ में लगी हुई मिट्टी को घोलकर पिलाने से) गिरते हुए गर्भ को रोक देती है^{२४} ।
- (२३) श्वेत अपमज्जिता (के चूर्ण) को मधु मिलाकर अजा-दुग्ध के साथ पीने से गर्भपात रुक जाता है^{२५} ।
- (२४) पाणवत-मल को ताम्बूल-स्मरस के साथ तीन दिन पान करने से गर्भ निरुद्ध होकर रुक जाता है^{२६} ।
- (२५) शर्करा, बिस एवं तिल (के चूर्ण) को शहद के साथ खाने से गर्भपात का भय तीर्थ-सेवन से पाप-भय के नाश के सदृश ही नष्ट हो जाता है^{२७} ।
- (२६) न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, काला (त्रिवृत्), पलाश एवं कमल के पत्तों से निर्मित, शृत एवं दाडिम से संस्कृत पञ्च-यूष गर्भपात में हितकारी है^{२८} ।
- (२७) बला, वृषत्पर्णी, शालपर्णी, दाडिम एवं बिल्व-शलाटु से युक्त पेया गर्भस्त्राव का शमन करती है^{२९} ।
- (२८) गर्भस्त्राव में दुग्ध पान हितकारी है^{३०} ।
१. (अ) चण सं० शां० ८/२० को चक्राणि टीका, अ० सं० शां० १/६२ को इन्दु टीका
(आ) गर्भस्थापन औषधियाँ (च० सं० सू० ४/१८-(४९), च० सं० शां० ८/२०, अ० सं० सू० १५/४८, अ० सं० शां० १/६२, का० सं० छि० १०/१७७ से १८१) (पु० २३८ से २४१)
(सु० सं० शां० २/३२ की डल्लण टीका)
(अ) लब्धगर्भाशय लक्षणादिनस्यदानं गर्भस्थापनार्थं, स्थितगर्भाशय मासवयल्यान्तरे पुत्राप्तजननार्थं नस्यदानमिति ॥
(आ) शुक्लमास्यादिका नारी पुष्योदयत्वात् लक्षणायात्कल्कम्..... पुत्रयुतोत्पन्नानाथ स्थितये च तत्कालमपि पीतो व्यक्तस्यापि पुत्रस्य परिस्थापनं रक्षाभिधानां स्थितिं करोति । (अ० सं० शां० १/६१ की इन्दु टीका)
(इ) लक्षणाभूतम्..... यस्या पुत्रोत्पद्यते तयोत्पन्नो वा स्थितिं न लभते, त्विरं न जीवति तथैव पातव्यमित्यर्थः ॥
(अ० ह० शां० १/४१ व ४२ की अरुण० टीका)
(पृष्ठ ३४३ में क्रमशः ...)

- (२९) काकोली, क्षौरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, मधुक, मुद्गापर्णी, माधपर्णी आदि जीवनीय
३. न्यग्रोधादिशुक्रसिद्धिर्वाचो क्षीरसंधिषोः अतश्चैवाक्षमात्रं प्राशयेत्, प्राशयेद्वा केवलं क्षीरसंधिः, पयोत्पलकुमुदिक-जल्लक्षणाद्यैः समभुशर्कराम्, लेहार्थं दद्यात्, शृङ्गाटकपुष्पकवीजकशेरुकान्, भक्षणाार्थं, गन्धप्रवृद्धवसितोत्पलशालूको-दुग्धशालादुन्यग्रोधशुक्राणि वा पाययेदनामानेन पयसा, पयसा चैनां क्वातिवलाशालिषष्टिकेभ्युत्पलकोलीभूतेन समभुशर्करं रकशालीनामोदनं मृदुसुगन्धिशीतलं भोजयेत्, लावकपिञ्जलकुङ्कुमशम्बरशराहरिणकालपुच्छकसेन वा घृतसुसंस्कृतं सुवर्धिशिरोपवातदेशस्थानं भोजयेत्, क्रोशशोकायसव्यव्यायामायेभ्यश्चाभिरक्षेत्, सौम्याभिरचैनां कथाभिर्मनोभुङ्क्ताभिरपसीत, तथाऽप्या गभीरलिष्टति ॥ (च० सं० शां० ८/२४)
४. उवाचेजीवनीयशुक्रक्षीरपानौ अतश्चैव स्तवति रक्तं कोष्ठागारिकागामृतिपण्डसमाङ्गाधातकीभुसुभवनमार्जिका-गैरिकसर्वसंसाञ्जनचूर्णं मधुनावलिष्टाद्, यथालाभं न्यग्रोधादिवर्क प्रवालकल्कं वा पयसा पाययेत् उत्पलादिकल्कं वा कशेरुशृङ्गाटकशालूककल्कं वा भूतेन पायसा, उदुम्बरफलीदककन्दक्वाथेन वा शर्करामधुमधुरेण शालिपिष्टम् ॥ (सु० सं० शां० १०/५७)
५. अतिस्निहितं तु रक्ते तत एवाक्षमात्रं प्राशयेत् । केवलादेव वा क्षीरसंधिः । पयोत्पलकुमुदिकजल्लं च समभुशर्करं लेहयेत् । धातकीगैरिकसर्वसंसाञ्जनचूर्णं वा समधु । न्यग्रोधादिवर्कपुत्रवालकल्कं वा । शशैर्वाहरिणसंधिं वा सक्षैर्द्रं पाययेत् । वृद्धिविदारिजीवन्तीर्वा पयसा । नीलोत्पलसितापक्वलोहचन्दनादि वा तन्दुलान् वा शरासायनरेण । गन्धप्रियङ्गुवसितोत्पल-शालूकोदुम्बरशलादुन्यग्रोधशुक्राणि वाऽऽजेन पयसा । कसेरुकमुण्डलशृङ्गाटककाशमरीरुषकद्राक्षाभारिवापौण्डरीकाननो-त्पलकदम्बबीजक्वाथेन वा शर्करामधुमधुरेण । शालिपिष्टं जीवनीयभूतं वा क्षीप्य । बलाडिबलाशालि-षष्टिकेशुत्पलकाकोलीभूतेन च पयसा समभुशर्करेण रकशालोदेन सुशीतं भोजयेच्छीतवीर्यजङ्गलसेन वा । सौम्याश्च मनोभुङ्क्ताः कथाः ॥ (अ० सं० शां० ४/५५)
६. समिताक्षीद्रकुमुदकमलोत्पलकेशस्य ॥ ३॥
लिह्यात् क्षीरशृतं खादच्छृङ्गाटककसेरुकम् । पिबेत्कालाञ्जशालूकबालोदुम्बरकपयः ॥ ४॥
भूतेन शालिकाकोलीद्विबलाभक्षुक्षुभिः । पयसा रकशालान्नमद्यात्समभुशर्करम् ॥ ५॥
रसेनां जाङ्गलेः ॥ ६॥ (अ० ह० शां० २/३ से ६)
७. मृत्कोष्ठागारिकागैहसम्भवा नवमक्षिका । समङ्गा धातकीपुष्पं गैरिकं च रसाञ्जम् ॥ ८१॥
तथा सर्जरसश्चैतान्यथालाभं विचूर्णयेत् । तच्चूर्णं मधुना लिह्याद् गर्भपातप्रशान्तये ॥ ८२॥
कशेरुत्पलशृङ्गाटककल्कं वा पयसा पिबेत् ॥ ८३॥ (पा० प्र० चि० ७०)
८. लज्जालुधातकीपुष्पमुत्पलं मधुलोषकम् । जलस्थया स्थिया पीतं गर्भपातं निवारयेत् ॥ ३॥
पतन्तं स्तम्भयेद्गर्भं कुलालकामृतिका । मधुच्छगपयः पीता किं वा श्वेताऽपमज्जिता ॥ ४॥
पारावतमलः पीतश्च्यवै ताम्बूलवारिणः । मधुभिर्गोभक्षितो रक्तं स्तम्भयेन्निरुद्धवत् ॥
शर्कराबिसितं समांशकं, माक्षिकेण सह भक्षये यदा । नास्ति गर्भपतनोदयत्वं पयं पापशीतिरिव तीक्ष्णसेवया ॥
मृत्कोष्ठागारिका गैहसम्भवा नवमृतिका । समङ्गा धातकीपुष्पं गैरिकं च रसाञ्जम् ।
तथा सर्जरसश्चैतान्यथालाभं विचूर्णयेत् ॥
तच्चूर्णं मधुना लिह्यानात् प्रदशान्तये । कसेरुत्पलशृङ्गाटककल्कं वा पयसा पिबेत् ॥ (पा० १० स्त्रीरोग चिकित्सा)
९. न्यग्रोधादिव्यासवत्यलक्षकालापानसर्वैः ॥ ५॥
यत्क्षेत्रेः कमलानां च घृतदाडिमसंस्कृतः । गर्भव्यवन्दाहयोः ॥ ५२॥
मुखः पञ्चयूषोऽयं हितः ... ॥ ५३॥
बलावृषत्पर्णं शालपर्णी स्याद्दाडिमं बिल्वशलाटुकम् ॥ ८०॥
...शमयतुदीर्घम् असुप्तं गर्भपरिस्त्रवं च ॥ ८१॥ (का० सं० छि० ४)
...गर्भस्त्रावे च दारणे । (का० सं० छि० २२/४४)

गण है। यह गण स्वादु तथा गर्भ-संस्नानकृत^१ अर्थात् गर्भ को गिरने से रोकने वाला है। महर्षि चक्र एवं वाग्भट ने भी जीवनीय गण को गर्भस्थायक माना है^२।

नोट- महर्षि सुश्रुत एवं अष्टांगसंग्रहकार ने अधिकोश योगों को "रक्त की अप्रवृत्ति" की चिकित्सा लिखकर वर्णित किया है। अन्य आचार्यों ने उसी भाँति की चिकित्सा को सामान्य चिकित्सा के अन्तर्गत ही समाविष्ट किया है। वस्तुस्थिति में दोनों ही वर्णनों में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि अत्यल्प रक्तसाव कभी-कभी बिना चिकित्सा के ही ठीक हो जाता है, परन्तु रक्तसाव की मात्रा बढ़ने में गर्भ के स्तवित हो जाने का भय बढ़ जाने के कारण चिकित्सा अत्यन्त आवश्यक हो जाती है।

- i) Use of the drugs described as *garbhashāpāna* is beneficial.
- ii) Oral use or nasal instillation of juice of *lakṣamaṇā* should be done.
- iii) One *akṣa ghṛta* extracted from milk, medicated with leabuds of *nyagrodhādi* group of drugs should be given.
- iv) Only *ghṛta* extracted from milk is beneficial.
- v) Pestled saffron of *padma*, *upala* and *kumuda* should be given with either only honey and sugar or adding *ghṛta* extracted from milk.
- vi) *Śṛṅgāṭaka*, *kaśeru* and *puṣkaraḍḍija* should be prescribed for eating.
- vii) *Gandhapṛyaṅgu*, *astiopala*, *śālūka* (lotus root), young unripe fruit of *udumbara* and leabuds of *nyagrodha* should be given with goat's milk.
- viii) Very soft, cool, cooked red *śālī* rice incensed with fragrant articles, mixed with milk which is already boiled with roots of *balā*, *athalā*, *śālī*, *saśika*, *iṣṭu* and *kākoḥ* should be given with honey, sugar or else the same rice should be given with meat soup of wild animals or birds having *śīta vīrya*.
- ix) Meat soup of *lāvā* (a kind of quail), sparrow, antelope, rein-deer, rabbit, deer and black-tailed deer mixed with *ghṛta* alongwith cooked red *śālī* rice should be served to the pregnant woman sitting in cool and airy place.
- x) Powdered *dhātākī*, *gairika*, *sarjara* and *rasājāna* should be given with honey.
- xi) Paste of tender leaves or stem bark of *nyagrodhādi* group of drugs with or without milk should be given.
- xii) Milk either medicated with *jīvanīya* group of drugs or mixed with paste of *śālī* rice should be prescribed.
- xiii) In case of excessive bleeding powders of available things out of clay of the house of an insect named *koṣṭhāgarikā*, *samaṅgā*, flowers of *dhātākī* and *vanamallikā*, *gairika*, *sarjara* and *rasājāna* should be prescribed with honey.

१. काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षकौ तथा। मेदा चान्दा मलमेदा जीवती मधुकं तथा ॥

मुद्रपर्णी माषपर्णी जीवनीयो गणस्त्वयम्। जीवनीयो गणः स्वादुर्गर्भसंस्नानकृद् गुरः ॥ (शा० सं० मध्य ख० ६। १७, १८)

२. च० सं० शा० ८/२० एवं अ० सं० शा० १/६२ (पृष्ठ २३८ से २४०)

- xiv) Paste of either *upalādi* group of drugs or *kaśeru*, *śṛṅgāṭaka* and *śālūka* (rhizome of lotus) or only *upala* should be given with boiled milk.
- xv) Pestled *śālī* rice alongwith sugar and honey should be prescribed with sweetened decoction of either fruits of *udumbara* or *ulaka kanda* (rhizomes of aquatic plants such as lotus etc).
- xvi) The blood of rabbit, *eṇa* (a species of deer or antelope) and deer with honey should be prescribed.
- xvii) Powder of *vrddhi*, *vidarī* and *jīvanī* with milk should be given.
- xviii) Powder of *nīlotpala*, *śīva* (*dūrva*), reddened clay of potter's kiln and *candānādi* group of drugs should be given with rice water or juice of *vāṣā*.
- xix) Decoction of *kaśeru*, *mṛgāla*, *śṛṅgāṭaka*, *kāśmarī*, *paraśaka*, *drākṣā*, *sārvā*, *prapaundarikā*, *anarī*, *upala* and *kadamḍabija* with honey and sugar should be prescribed.
- xx) Paste of *kānū*, *abja*, *śālūka* and unripe fruit of *udumbara* should be given with milk.
- xxi) Powders of *lajjālū*, flowers of *dhātākī*, *upala* and *lodhra* with honey if given to the woman seated in water prevent abortion.
- xxii) Use of clay of potter's hands dissolved in water prevents abortion.
- xxiii) Powder of white *aparājītā* with honey taken with goat's milk prevents abortion.
- xxiv) Feces of pigeon with juice of betel leaves used for three days prevents abortion without any complication.
- xxv) Use of sugar, powder of *bisa* and black *tīla* with honey prevents abortion.
- xxvi) Soup prepared with the tender leaves of *nyagrodha*, *udumbara*, *aśwathā*, *plakṣa*, *trivṛt*, *palāśa* and lotus then mixed with *dāḍima* and *ghṛta* is beneficial.
- xxvii) Use of liquid prepared with *balā*, *vṛṣaparnī*, *śālaparnī*, *dāḍima* and unripe young fruit of *bilva* prevents abortion.
- xxviii) Use of milk during abortion is beneficial.
- xxix) Use of *jīvanīya* group of drugs i.e. *kākoḥ*, *kṣīrākākoḥ*, *jīvaka*, *ṛṣabhaka*, *medā*, *mahamedā*, *jīvanī*, *madhuka*, *mudgaparnī* and *māḍgaparnī* is beneficial.

मुद्गःमुद्गः रक्तसाव की चिकित्सा (Treatment of recurrent bleeding)

गर्भेणी स्त्री के गर्भ से यदि बार-बार रक्तसाव हो तो उसे रोकने के लिए उत्तलादिगण की औषधियों से सिद्ध दुग्ध का पान करायें^१।

In case of recurrent bleeding she should be given milk medicated with the drugs of *utpalādi* group.

१. गुर्विण्या गर्भतो रक्तं खवेद्यदि मुद्गमुद्गः। तत्रितोषाय सा दुग्धमुत्तलादिभ्यः पिबेत् ॥ (पा० प्र० चि० ७०/७४)

गर्भस्त्राव से पीड़ित स्त्री के लिए उपयुक्त आचार या विहार (Beneficial mode of life for a woman having abortion)

- (१) क्रोध, शोक, आगम (शकावट), व्यायाम एवं व्यायाम आदि से रक्षा करने चाहिए ।
- (२) सौम्य तथा मनोजुक्त कथाओं आदि से मन को प्रसन्न करें^{१,३} ।
- (i) She should avoid anger, grief, tiredness, coitus and exercise.
- (ii) She should be made cheerful by pleasing and desired stories.

गर्भ के व्यवस्थित हो जाने पर चिकित्सा (Treatment after stability of garbha)

गर्भ के व्यवस्थित हो जाने पर उदुम्बर-शलाटु (गुलर के कच्चे फल) से सिद्ध गोक्षीर का सेवन करना चाहिए ।
Once the garbha is stabilized or abortion is prevented, cow's milk medicated with unripe young fruits of udumbara should be prescribed.

(३) गर्भस्त्राव के उपद्रवों की चिकित्सा (Treatment of complications of abortion)

(अ) गर्भसुरण की चिकित्सा (Treatment of excessive quivering of fetus)

गर्भ में बार-बार सुरण होने पर उसके संधारण के लिए उत्तलादि गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर पीने को देना चाहिए ।
In case of frequent and/or excessive quivering of fetus milk medicated with upaladi group of drugs should be prescribed.

(आ) गर्भस्त्राव में वेदना (अत्यधिक) की चिकित्सा (Treatment of excessive pain)

(१) महासह, क्षुद्रसह, मधुक, क्षुद्रा तथा कण्टकारी से सिद्ध शर्करा एवं मधु-युक्त दुग्ध देने से गर्भिणी की वेदना का नाश होता है^४ ।

(२) कुश, काश, उरुबुक तथा गोक्षुर को मूल से साधित एवं शर्करा से युक्त अथवा श्वदंष्ट्रा, मधुक, क्षुद्रा, एवं अम्लान से सिद्ध शर्करा एवं मधु-युक्त दुग्ध गर्भिणी के शूल में लाभकारी है^{५,७} ।

(३) प्रसंसमान गर्भ की चिकित्सा के अन्तर्गत वर्णित भा० प्र० एवं यो० २० की चिकित्सा (पृष्ठ ३३८) ।

(४) दुग्ध के साथ अन्न का भोजन करने वाली, शूल युक्त गर्भस्त्राव से पीड़ित स्त्री को कसेर, शृंगाटक, पत्रक, उत्तल, मुद्रापर्णी एवं मधुक (का छाथ या चूर्ण) दुग्ध में मिलाकर शर्करा डालकर पीना चाहिए^९ ।

१. क्रोधशोकआयसव्याजवायामेधरजामिश्रित, सौम्याग्निपचनं कथामिर्मनोजुक्ताभिरुच्यतीति ॥ (च० सं० शा० ८२४)

२. सौम्याग्रमनोजुक्ताः कथाः ॥ (अ० सं० शा० ४५५)

३. व्यवस्थिते च गर्भे गव्येनोदुम्बरशलाटुसिद्धेन पयसा भोजयेत् ॥ (सु० सं० शा० १०५७)

४. गर्भसुरणे मुहुर्मुहुस्तत्सन्ध्यागार्धं क्षीरपुस्तलादिभिर्द पाययेत् ॥ (सु० सं० शा० १०५७)

५. वेदनाया महासहक्षुद्रसहामधुकश्वदंष्ट्राकण्टकारिसिद्धं पयः शर्कराक्षौद्रमिश्रं पाययेत् ॥ (सु० सं० शा० १०५७)

६. कुशकाशोर्बुकाणां मूलैर्गोक्षुरन्म च ॥ ७९ ॥

शुतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शूलहरम् ॥ ८० ॥ (भा० प्र० चि० ६०)

शर्करा मधुसंयुक्तं गर्भिणी वेदनाहरम् ॥ ८० ॥ (भा० प्र० चि० ६०)

७. कुशकाशोर्...वेदनाहरम् (भा० प्र० संदृश हो केवल 'मधुकशलाटु' पद्यान्तः पाठान्ते से)

कसेरशृङ्गाटकपद्मकोत्तल समुद्रगणामधुक सशर्करम् । सशूलगर्भसुतिपीडिताज्जला पयो विमिश्रं पयसाऽभुजिष्येत् ॥ (यो० २० स्त्री गर्भे० चि०)

i) Milk medicated with mahācāhā, kṣudrasahā, madhuka, śwadamṣṭrā and kaṇṭakāri then mixed with honey and sugar should be prescribed.

ii) Milk treated with roots of kuśa, kāsa, urubūka and gokṣura and mixed with sugar or else treated with śwadamṣṭrā, madhuka, kṣudrā and amlāna and mixed with sugar and honey is beneficial.

iii) The treatment prescribed for prastamsamāna garbha is also beneficial.

vi) She should be given milk mixed with sugar and decoction or powder of kaseru, śrīgāika, padmaka, upala, mudgaparṇi and madhuka and the cereals with milk in diet.

(इ) मूत्रसङ्ग-चिकित्सा (Treatment of retention of urine)

मूत्रसङ्ग में दर्भादि (कुश, काश नल, दर्भ, कण्डेक्षुक) से सिद्ध शर्करा या मधु मिश्रित क्षीर, या तुणपंचमूल (शाली, इक्षु, कुश काश, शर) के कल्क से साधित क्षीर पान करना चाहिए ।

To treat retention of urine the milk treated with darbhādi group (kuśa, kāsa, nala, darbha and kandeṣuka) of drugs and mixed with honey or sugar or else treated with paste of tripaṇcāmūla (kuśa, kāsa, śālī, iksu, śara) should be prescribed.

(ई) आनाह-चिकित्सा (Treatment of Jaundice)

आनाह में हिगु, सौवर्चल (लवण), लघुण एवं वचा से सिद्ध क्षीर में मधु तथा शर्करा मिलाकर या अकेले ही पीने को दे^१ ।

Milk medicated with hingu, sauvarcala sal, laṣuna and vacā with or without sugar and honey should be prescribed.

(उ) अदृष्ट शोणित-वेदना-चिकित्सा (Treatment of pain without bleeding)

जब दृष्ट रक्तस्राव के बिना ही वेदना ही तो निम्न चिकित्सा करें । इस चिकित्सा से वेदना शीघ्र ही नष्ट होकर गर्भ भी वृद्धि को प्राप्त होता है^४ ।

१. मूत्रसङ्गे दर्भादि सिद्धम् (पयः शर्कराक्षौद्रमिश्रं पाययेत्) ॥ (सु० सं० शा० १०५७)

(कुशकाशनलदर्भकण्डेक्षुका इति तुणसंज्ञकः) ॥ (सु० सं० सू० ३८/७५)

२. तुणपंचकमूलानां कल्केन विपचेत्ययः । तत्रयो गर्भिणी पीत्वा मूत्रसङ्गादिमुच्यते ॥

शालीक्षुशकाशैः स्याच्छ्रेण तुणपञ्चकम् ॥ (भा० प्र० चि० ७०/८४ व ८५; यो० २० स्त्री० गर्भ० सेग चि०)

३. (अ) आनाहे हिङ्गुसौवर्चललघुणवचासिद्धम् (पयः शर्कराक्षौद्रमिश्रं पाययेत्) ॥ (सु० सं० शा० १०५७)

(आ) पक्वं वचासोनायाम् हिङ्गुसौवर्चलान्वितम् । आनाहे तु पिबेद् दुग्धं गुर्विणी सुखिनी भवेत् ॥ (भा० प्र० चि० ७०/८३ एवं यो० २० स्त्री० ते०)

४. एवमुपक्रान्ताया उपावर्तते रुगो गर्भश्चाप्यायते ॥ (सु० सं० शा० १०५७)

- (१) मधुक, देवदार, पयस्या^१ अथवा इन्हीं के साथ मज्जिष्ठा^१ से सिद्ध दुग्ध पीने को दें^{१,३} ।
 (२) अश्मन्तक, शलावरी एवं पयस्या से सिद्ध दुग्ध^१ अथवा इन्हीं के साथ ताम्रवल्ली से सिद्ध दुग्ध पीने को दें ।
 (३) अथवा विदारिगन्धादि गण की औषधियों से सिद्ध दूध दें^{१,३} ।
 (४) अथवा बृहतीद्वय (बड़ी एवं छोटी केटी), उत्तल, शलावरी, सारिवा, पयस्या एवं मधुक से सिद्ध दुग्ध पीने को दें^१ ।

(५) श्वदंष्ट्रा के स्वरस से सिद्ध दुग्ध या घृत दें^१ ।

(६) पलाण्डु के स्वरस से सिद्ध घृत मधु के साथ दें^१ ।

In case of pain without bleeding following preparations should be given, with this pain subsides and fetus also grows.

- i) Milk medicated with *madhuka*, *devadāra*, *payasyā* with or without *majjishṭhā*.
 ii) Milk medicated with *āśmanaka*, *śalāvārī*, *payasyā* with or without *tāmravalī*.
 iii) Milk medicated with *vidāriṅgandhādi* group of drugs.
 iv) Milk medicated with *bṛhātīdwyā*, *utpala*, *śalāvārī*, *sāriṇvā*, *payasyā* and *madhuka*.
 v) Milk or *ghṛta* medicated with juice of *śwadaṅgīrā*.
 vi) *Ghṛta* treated with juice of onion and mixed with honey.

(ऊ) दाहहि-चिकित्सा (Treatment of burning sensation etc.)

(१) दाहहि उपद्रवों में क्षिप्र एवं शीत क्रिया करनी चाहिए^१ ।

(२) शाली, इक्षु, कुश, काश एवं शर, यह तुणपञ्चक है इस तुणपंचमूल (के कल्क से सिद्ध क्षीर) का पान तथा दाहहि तथा मूत्रसंग-नाशक है^१ ।

- i) Unctuous and cold drugs and methods should be used.
 ii) Milk medicated with *trīṇapāṇcamūla* consisting of *śālī*, *ikṣu*, *kūśa*, *kāśa* and *śara* relieves thirst, burning sensation and urinary retention.

(ए) ज्वर-चिकित्सा (गर्भजातोपद्रव-ज्वर) (Treatment of fever due to complication of abortion)

अपप्रजाला अर्थात् पतितगर्भा (गर्भपात के बाद) स्त्री को अथवा स्तन्यावतरण होने पर उत्पन्न ज्वर में प्रकुपित दोष

- अथादुष्टशोणितवेदनायां मधुकदेवदारमज्जिष्ठापयस्यासिद्धं पयः पाययेत्, तदेवाश्मन्तकशलावरीपयस्यासिद्धं विदारिगन्धादिसिद्धं वा, बृहतीद्वयोत्पलाशलावरीसारिवापयस्यामधुकसिद्धं वा। (सु० सं० शा० १०/५७)
- अदुष्टशोणितां तु मधुकपयस्यामुत्पलाशः सिद्धं पयः पाययेत् । ताम्रवल्लीश्वदंष्ट्राशलावरीपयस्याभिर्वा । विदारिगन्धादिपानेन वा । श्वदंष्ट्राश्वरसशरीरसिद्धं वा सारिः ॥ पलाण्डुसमिद्धं वा सक्षौद्रम् । (अ० सं० शा० ४/६)
- क्षिप्रशोणिक्रियान्तेषु दाहादिषु समाचरेत् ॥
(भा० प्र० चि० ७०/७९ तथा यो० १० स्त्री गर्भतो चि० शीत के स्थान में शीतः पाठ)
- शालीक्षुकशकाशैः स्याच्छरेण तुणपञ्चकम् । एषां मूलं तुषादाहभित्तमुद्धमूत्रसङ्गहत् ॥ (भा० प्र० चि० ७०/८५)

के लिए वर्णित विशिष्ट विधान द्वारा संशमन अर्थात् दोष का संशमन एवं पावन करना चाहिए^१, अर्थात् विशिष्ट लक्षणों के आधार पर दोष-प्रकोप का ज्ञान कर उस दोष की संशमन चिकित्सा करे ।

In a case of fever either to a woman who had abortion or milk fever, the aggravaated *dosha* should be normalised with the treatment specifically prescribed for that *dosha*. The aggravaation of *dosha* should be diagnosed on the basis of specific clinical features.

गर्भजात की मासानुमासिक चिकित्सा (Monthly treatment of abortions)

गर्भजात या पात की मासानुमासिक चिकित्सा का वर्णन सम्भवतः उन रत्नावली के लिए है जिनमें कि बारम्बार गर्भपात हो जाता है, उनमें यह प्रथम मास से ही प्रारम्भ की गई चिकित्सा शायद गर्भजात प्रतिषेधात्मक रूप से कार्य करती हो । इसी आशय का स्पष्टीकरण टीकाकार डल्लण ने गदास के वाक्य का उद्धरण देते हुए किया है कि इन औषधियों के पूर्व प्रयोग से गर्भ उचित प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है^१ ।

इन मासानुमासिक वर्णित औषधियों को (चूर्ण या कल्क को) दुग्ध के साथ प्रयोग करना चाहिए^{१,३,४,५} ।
 The recipes prescribed under this heading are preventive medicines aimed at treating the cases of habitual or repeated abortions. By use of these drugs on specific months i.e. drugs prescribed for first month etc. the fetus grows properly upto full term.

Powder or paste of the drugs is to be used with milk. The drugs to be given during specific months are given hereunder:

(१) प्रथम मास में चिकित्सा (Treatment during first month of pregnancy)

मधुक, शाकबीज, पयस्या (क्षीरकाकोली?) तथा सुरदार^{१,३,४,५} ।

Madhuka, *śākabīja*, *payasyā* and *suraḍāra*.

(२) दूसरे मास में (During second month)

अश्मन्तक, कृष्ण तिल, ताम्रवल्ली (मज्जिष्ठा) एवं शलावरी^{१,३,४,५} ।

Āśmanaka, black *tila*, *tāmravalī* and *śalāvārī*.

(३) तीसरे मास में (During third month)

वृक्षादनी, पयस्या, प्रियङ्गु या लता, उत्तल एवं सारिवा^{१,३,४,५} ।

Vṛkṣādānī, *payasyā*, *priyāṅgu* or *lata*, *utpala* and *sāriṇvā*.

(४) चौथे मास में (During fourth month)

अनन्ता (दूर्वा), सारिवा, रादना, पद्मा (भागी) एवं मधुक^{१,३,४,५} ।

१. स्त्रीगणमापप्रजालायां स्तन्यावतरणे च यः । तत्र संशमनं कुर्याद्यथादोषं विधानवित् ॥

(अपप्रजालाः पतितगर्भाः स्त्रियः, तासां यो ज्वरः, तथा स्तन्यावतरणे च स्त्रीणां यो ज्वरः तत्र संशमनं कुर्यादिति विधानवित् । यथादोषमिति यस्य दोषस्य तत्र प्रकोपो भवेत्तस्य प्रत्यनीकं संशमनं कुर्यादित्यर्थः । संशमनसम्बन्धेन पावनमपि गृहीतम्-डल्लण) । (सु० सं० उ० ३९/१६७)

२. गदादसेन चैते गर्भजातचिकित्सवयोगाः प्रागेव गर्भजात्यापद इत्यनन्तरं पठिताः ॥

नोट- मासानुमासिक चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ३५०, ३५१ में देखें (सु० सं० शा० १०/६३ से ६५ की डल्लं टी०)

Ananā, sārivā, rāsivā, padmā and madhuka.

(५) पाँचवें मास में (During fifth month)

वृहतीद्वय, कारमरी (श्रीपर्णी या गम्परी), क्षीरिशुद्ध एवं त्वचा (क्षीरवृक्षों के कोमल पत्ते तथा छाल) एवं घृत^{१,३,३,४,५}।

Bṛhādīdvya, kśīrmarī, stem-bark and leafbuds of latex yielding trees and ghṛta.

(६) छठे मास में (During sixth month)

पुश्निपर्णी, बला (भा० प्र०-वला), शिशु, श्वद्वय तथा मधुपर्णिका^{१,३,३,४,५}।

Psūniparnī, balā or vālā, śiṣu, śvadvayā and madhuparnikā.

(७) सातवें मास में (During seventh month)

शृंगाटक, बिस, द्राक्षा, कश्यरू, मधुक तथा शक्र^{१,३,४,५} या बला^३।

Śṛṅgāṭaka, bīsa, drākṣā, kaśērū, madhuka and sugār or balā.

(८) आठवें मास में (During eighth month)

कपित्थ, बिल्व, वृहती, फटील, इशु एवं निदिधिका के मूलों से सिद्ध दुग्ध अष्टम मास में पीने को दे^{१,३,३,४,५}।
Milk, treated with roots of *kapitha*, *bilva*, *bṛhātī*, *paṭala*, *ikṣu* and *nidighika*.

(९) नवम मास में (During ninth month)

अनन्त, सारिका, पयस्या एवं मधुयष्टी से सिद्ध क्षीर पान करने को दे^{१,३,३,४,५}।

१. अत उर्ध्व मासगुप्तिकं वक्ष्यामः ॥५८॥

मधुकं शाकबीजं सोमलसारिका । च मधुयष्टिका ॥५८॥

वृक्षदानी पयस्या च तला चोत्तलसारिका । अनन्ता सारिका यस्ता पश्चा मधुकमेव च ॥६०॥

वृहतीयो कारमरी चापि क्षीरिशुद्धास्तत्त्वो घृतम् । पुश्निपर्णी बला शिशुः श्वद्वय मधुपर्णिका ॥६१॥

शृङ्गाटकं बिसं द्राक्षा कश्यर मधुकं सितम् ।

वस्त्रेते सप्तयोगाः स्फुरधरलोकसमापनाः । यथासंख्यं प्रयोक्तव्या गर्भस्त्रावे पयोयुताः ॥६२॥

कपित्थवृहतीबिल्वफटीलेशुनिदिधिकाः । मूलानि क्षीरसिद्धानि पायदेद् भिषगृष्टम् ॥६३॥

नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिकाः पिबेद् । क्षीरं शुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धं स्यादश्वत्थे हितम् ॥६४॥

सक्षीरा वा हिला शुण्ठी मधुकं सुरदार च । एवमाप्यायते गर्भस्त्रीत्रा रुक् चोपशाम्यति ॥६५॥

२. मधुकं शाकबीजं । अश्वत्थः कृष्णालिस्ताप्रवल्ली शलावरी ॥५३॥

वृक्षदानी सोमलसारिका । च मधुयष्टिका ॥५४॥

वृहतीद्वयकारमर्यक्षीरिशुद्धत्त्वो घृतम् । पुश्निपर्णी शिशुः ॥५५॥

..... कश्यरू बला । सहेतान् पयसा योगधरलोकसमापनाम् ॥५६॥

क्रमान्तरास्तसु मासेषु गर्भे स्ववति योजयेत् । (रिक्त स्थान सुश्रुत सं० सदृश)।

कपित्थबिल्ववृहतीफटीलेशुनिदिधिकात् ॥५७॥

मूलैः शुण्ठी प्रशुद्धीत क्षीरं मासे तथाऽष्टमे । नवमे सारिकाऽनन्तापयस्यामधुयष्टिभिः ॥५८॥

(क्रमशः पृष्ठ ३५९ में)

Milk treated with *ananā*, *sārivā*, *payasyā* and *madhupasyā*.

(१०) दशम मास में (During tenth month)

शुण्ठी एवं पयस्या से सिद्ध^{१,४} क्षीर अथवा शुण्ठी, मधुयष्टी एवं सुरदार से सिद्ध क्षीर^{१,३,३,४,५} अथवा केवल पयस्या से सिद्ध क्षीर^{३,४} का प्रयोग करें इस प्रयोग से गर्भ की तीव्र पीड़ा भी शान्त हो जाती है^१।

Milk treated with either *śuṇṭhī* and *payasyā* or *śuṇṭhī*, *madhupasyā* and *surdārā* or only *payasyā*. Use of this prescription relieves even very severe pain.

(११) ग्यारहवें मास में (During eleventh month)

क्षीरिका, उत्तल, समझा-मूल, तथा शिवा के कल्क को दुग्ध के साथ एकादश मास में शूल की शान्ति के लिए गर्भिणी स्त्री को पीना चाहिए^{४,५}।

For relief of pain during eleventh month of pregnancy, the woman should be prescribed paste of *kṣīrikā*, *utpala*, *samāṅgā* root and *śivā* alongwith milk.

(१२) बारहवें मास में (During twelfth month)

सिता, विदारी, काकोली, क्षीरी (वशेलोवन या क्षीरकाकोली) तथा मृणालिका को (दुग्ध के साथ) बारहवें मास में शूल के नाश के लिए गर्भिणी पान करे, इसके प्रयोग से गर्भ की तीव्र पीड़ा का शमन होता है तथा गर्भ की वृद्धि होती है^{४,५}।

(पृष्ठ ३५० से क्रमशः)

३. मधुकं शलावरी ॥५४॥

वृहतीद्वय गर्भे स्ववति योजयेत् ॥

कपित्थबिल्व निदिधिवर्जैः ॥५८-५९॥

..... गामरदादयः ॥६०॥ (अ० ह० शा० २/५४ से ६०; अ० सं० सदृश ही)

४. मधुकं शलावरी ॥६६॥

वृक्षदानी पयस्या च प्रियङ्गुत्तल सारिका । मधुकमेव च ॥६७॥

वृहतीयो पुश्निपर्णी वला मधुपर्णिका ॥६८॥

शृङ्गाटकं समापनाः ॥६९॥

यथा संख्यं एवं गर्भो न पतति गर्भशूलञ्च शाम्यति ॥७०॥

कपित्थ दापयेद्भ्रूपाष्टमे ॥९१॥

नवमे सारिका ॥९२॥

क्षीर सक्षीर ॥९३॥ (सुश्रुत सं० सदृश ही)

क्षीरिकाभुसलं दुग्धं समझामूलकं शिवाम् । पिबेदेकादशे मासि गर्भिणीशूलशान्तये ॥९४॥

सिता विदारी काकोली क्षीरी चैव मृणालिका । गर्भिणी द्वादशे मासि पिबेच्चूलजम्बीरधम् ॥९५॥

एवमाप्यायते गर्भस्त्रीत्रा रुक् चोपशाम्यति ॥९६॥ (भा० प्र० वि० ७०/८६ से ९६)

५. मधुकं शलावरी । (अ० सं० सदृश)

वृक्षदानी मधुकमेव च । (सु० सं० सदृश)

वृहतीद्वय योजयेत् ।

कपित्थ निदिधिवर्जैः । ॥ ७१॥ (अ० सं० के ५५ से ५८ सदृश)

नवमे सुरदार च । (सु० सदृश) (यो० ७० स्त्री गर्भी० वि०)

क्षीरिकाभुसलं काकोलीक्षीरिकाश्च रुक्चोपशाम्यति । (भा० प्र० वि० ७०/४४ के ९६ सदृश;

यो० ७० स्त्री गर्भी० वि०)

Use of *śiñ, vidārī, kākolī, kṣīrā* and *mṛnālīkā* with milk relieves pain during twelfth month and is beneficial for proper development of the fetus.

गर्भ-चलन की चिकित्सा (Treatment of garbha-calanā)

महर्षि हारीत एवं योगरत्नाकर ने गर्भ-चलन की भी मासानुसारिक चिकित्सा का वर्णन किया है। गर्भ का चलायमान होना उसकी अपरिहार्यता का द्योतक है अतः इसकी चिकित्सा करने से साधारणतया गर्भ के स्थित होने अर्थात् गर्भपात न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा संभव है कि यहाँ पर आचार्यों का चलायमान से तात्पर्य गर्भस्राव-प्रक्रिया की प्रारम्भ की अवस्था अर्थात् जब तक कि गर्भ परिहार्य है अर्थात् रोक जा सकता है से हो अथवा गर्भचलन का तात्पर्य गर्भ की अत्यधिक गतिशीलता (स्मन्दन) से हो।

The word *calana* or movement indicates the movement from its own normal place, thus the question of prevention of expulsion of fetus in case of *garbha-calanā* should not have arisen. However, in the classics, month-wise treatment of this condition has also been prescribed, which shows that probably this is also a condition of threatened abortion or excessive quivering.

(अ) गर्भ-चलन होने पर सामान्य चिकित्सा (General treatment of garbha-calanā)

मधुक, बिस, मृणाल, पञ्चकिञ्जल्क का कल्क अथवा घन, अतिविषा, ऐन्डबीज, उशीर तथा नीर को समान मात्रा में ले कल्क बनाकर सिला मिलाकर स्त्री के गर्भ-चलन होने पर पीने को देना श्रेयस्कर है^१।

Either paste of *madhuka, bīsa, mṛnālā* and saffron of *padma* or *ghana, ativiśā, āindrabijā, uśīra* and *nīra* taken in equal quantity and pestled should be mixed with sugar and given to the woman suffering from *garbha-calanā*.

(आ) गर्भ-चलन की मासानुसारिक चिकित्सा (Monthwise treatment of garbha-calanā)

(१) प्रथम मास में (During first month)

यदि प्रथम मास में गर्भ में चलन हो तो मधुक या ज्योष्ठिका, मुद्गीका, चन्दन तथा रक्तचन्दन को (कल्क को) दुग्ध (गोदुग्ध) में मिलाकर पीने से निश्चित रूप से गर्भ स्थिर हो जाता है^{१,३}; अथवा नीलोत्पल, बाला (सुगन्धबाला), भृंगारू तथा कसेरु को शीतल जल से पीसकर दूध से साथ मिलाकर पीना चाहिए; इससे गर्भ का पात नहीं होता तथा शूल की भी शांति होती है^३।

In *garbhacalanā* during first month use of pestled *madhuka* or *jyesthikā, mṛdwiḥkā, candan* and *red candana* with milk definitely stabilizes fetus or else use of *nīlotpala, bālā, śṛṅgāḍāka* and *kāśērū* pestled with cold water and mixed with milk prevents expulsion of fetus and also relieves pain.

(२) द्वितीय मास में (During second month)

द्वितीय मास में गर्भ-चलन होने पर मृणाल तथा नागकेसर को दूध में घोलकर पीना चाहिए^{१,३}; अथवा इनके ही

१. मधुकाविसमूणालं पद्माकिञ्जल्ककल्कं, वनमतीविषभैरत्रं बीजमौशीरनीपम् ॥

समकुतमधुकल्कं देयमशुप्रपने । हितमपि युवतीनां गर्भचाले सिलाढ्यम् ॥ १२॥ (हा० सं० तुतीयस्थान ५१/१२)

नोट-गर्भचलन की मासानुसारिक चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ३५४ में देखें।

साथ तगर, कमल, बिल्व तथा कर्पूर को अजा-क्षीर के साथ पीसकर तथा अजा-क्षीर में ही मिलाकर पीने को देना चाहिए^१।

In case of *garbhacalanā* during second month *mṛnālā* and *nāgakeśāra* mixed with milk or else above drugs with *ajara, kamala, bilva* and *karpūra* pestled with goat's milk and mixed with the same should be given for drinking.

(३) तृतीय मास में (During third month)

यदि तृतीय मास में गर्भ-चलन हो तो मूषक-किट्ट एवं शर्करा को दूध में घोलकर^१ अथवा शर्करा एवं नागकेसर को दूध में घोलकर^३ देना चाहिए अथवा पद्मक, चन्दन, बालक और पञ्चनाल को शीतल जल के साथ पीसकर दूध में घोलकर पिलाना चाहिए^३; इन प्रयोगों से गर्भ का पात नहीं होता तथा शूल का भी शमन होता है^३।

Either pellets of rats or *nāgakeśāra* and sugar with milk or *padma, candana, bālaka* and *pañcānālā* pestled with cold water and mixed with milk should be given for drinking in *garbhacalanā* of third month. These things prevent expulsion of fetus and also relieve pain.

(४) चतुर्थ मास में (During fourth month)

चतुर्थ मास में गर्भ-चलन साथ ही तृष्णा, दाह, शूल एवं ज्वर^{१,३} होने पर उशीर, चन्दन, नागकेसर तथा घातकी-पुष्प (के कल्क या चूर्ण) के साथ घृत, मधु एवं दधि मिलाकर पिलाना चाहिए^१, अथवा कदलीमूल, उत्पल तथा बालक (के कल्क) को दूध में घोलकर पीने को देना चाहिए^३।

If *garbha-calanā* occurs in fourth month and is associated with thirst, burning sensation, pain and fever, then powdered *uśīra, candana, nāgakeśāra*, flowers of *dhātākī* and sugar mixed with *ghṛta*, honey and curd or pestled root of *kadalī* (benana), *utpala* and *bālaka* mixed with milk should be given.

(५) पंचम मास में (During fifth month)

पंचम मास में यदि गर्भ में कहीं भी चलन हो तो दाड़िम-पत्र एवं चन्दन (के कल्क या चूर्ण) को दधि तथा मधु मिला कर पिलाना चाहिए^{१,३}; अथवा नीलोत्पल, मृणाल, कौन्ती (हरेणु या मिर्गुडी-भेद), क्षीरे, केसर तथा पद्मक को (कल्क को) जल के साथ घोलकर पीने को देना चाहिए^३; इसके प्रयोग से गर्भपात नहीं होता तथा शूल का भी शमन होता है^३।

In case of *garbhacalanā* in any part during fifth month, powdered or pestled leaves of *dāḍīma* (pomegranate) and *candana* mixed with curd and honey or else pestled *nīlotpala, mṛnālā, kauṇṭī, kṣīrā, keśāra* and *padma* mixed with water should be given. Use of these prevents expulsion of fetus and also relieves pain.

(६) षष्ठ मास में (During sixth month)

षष्ठ मास में यदि गर्भ-चलन हो तो गैरिक, काली मिट्टी तथा गोमय-घस (गोबर की राख) से साधित जल को शीतल होने पर चन्दन एवं शर्करा मिलाकर पीने को देना चाहिए^{१,३}।

The water treated (boiled) with *gairīka* (red ochre), black clay and ash of cow-dung,

नोट-गर्भचलन की मासानुसारिक चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ३५४ में देखें।

then cooled and mixed with *cardana* and sugar should be prescribed for *garbha calana* in sixth month.

(७) सप्तम मास में (During seventh month)

यदि सातवें मास में गर्भ-चलन हो तो उशीर, गोक्षर, वन समंगा (लज्जालू), नागकेशर तथा पद्मक को मधु के साथ मिलाकर या मधुर करके पीने को देना चाहिए^{१,२}।

If *garbha calana* develops in seventh month then powdered or pestled *uśīra*, *gokṣura*, *ghana*, *samāṅga*, *māgakeśara* and *padmaka* mixed with water and honey or sweetened otherwise should be given.

(८) अष्टम मास में (During eighth month)

आठवें मास में यदि गर्भ-चलन हो तो लोष तथा मणिधिका के चूर्ण को मधु एवं दुग्ध के साथ पीने को देना चाहिए^{१,२}; इससे स्त्री को सुख प्राप्त होता है^१।

१. प्रथमे मासि गर्भस्य चलनं दृश्यते यदि । तदा मधुकर्मण्युक्तवन्दनं रक्तचन्दनं ॥ १॥
परमातोदितं पीतं तेन गर्भः स्थितो भवेत् ॥ २॥

द्वितीये मासि चलिते मृणाले नागकेशरम् । तृतीये मासि गर्भस्य चलनं दृश्यते यदा ॥ ३॥
तदा मधुकर्मिणं तु शर्करा पयसा भिन्ने । चतुर्थे मासि दाहश्च पिपासा शूलमेव च ॥ ४॥

ज्येष्ठा स्त्रीणं यदि गर्भश्चलते । तदोशीरचन्दननागकेशरायातकीकुसुमशर्करामधुमधुदीधि पाययेत् ।
पंचमे मासे चलिते गर्भे दाडिमीपत्राणि चन्दनं दधिमधुं च पाययेत् ।

षष्ठे मासि गैरिकं कृष्णपुटिकागोमयमस्य उदकं परितुल्यं शीतलं चन्दनं शर्करया सह भिन्ने ।
सप्तमे मासि गोक्षुसमङ्गापद्मकवनमुशीरनागकेशरं मधुरं पाययेत् ।

अष्टमे मासि रोषं मधुमणिधिकाश्च सह दुग्धेन पीतवतीनां चलिते गर्भे स्त्रीणं सुखं सम्पद्यते ॥ ५॥
(हा० सं० तृतीय० ५०/१ से ५)

२. चलनं प्रथमे मासि गर्भस्य यदि जायते । औषधं च तदा देयम् विचक्षणप्रेषयन्तैः ॥

मृदुका ज्योष्ठिका चैव चन्दनं रक्तचन्दनम् । गन्धं च पयसा पेयं स्थिरता जायते शुभम् ॥
नीलोत्पलं सबलं च शृङ्गाटं च कशेरुकम् । शीतलोधेन पिष्टा तु क्षीरणाडलोड्य तत्तिबेत् ॥

एवं न पतते गर्भः स च शूलः प्रशाम्यति । द्वितीये मासि गर्भस्य चलनं च भवेद्यदि ॥
पयसा च तदा पेयं मृणालं नागकेशरम् । तगरं कर्पूरं बिल्वं कर्पूण समन्वितम् ॥

अजोक्षीरेण तत्तिबेत् क्षीरेणाडलोड्य पूर्ववत् । तृतीये मासि चलनं जायते गर्भजं यदि ॥
पयसाऽऽलोदितं पेयं शर्करानागकेशरं । पद्मकं चन्दनं चैव बालकं पद्मनालकम् ॥

पिष्टा शीतेन लोधेन क्षीरेणाडलोड्य तत्तिबेत् । एवं न पतते गर्भः स च शूलः प्रशाम्यति ॥
यदि गर्भस्य चलनं चतुर्थे मासि जायते । तुष्णाशूलविदाहैश्च ज्येष्ठा च निपीडनम् ॥

क्षीरे च कदलीमूलमुत्पलं बालकं तथा । आलोड्य सम्भागेन भिन्नोपाध्यायते ॥
पञ्चमे मासि गर्भस्य चलनं कुञ्जचिद्रवेत् । दध्ना च मधुना पेयं दाडिमीपत्रचन्दनम् ॥

नीलोत्पलं मृणालं च कौन्तीक्षीरं तथैव च । केशरं पद्मकं चैव लोधेनाडलोड्य तत्तिबेत् ॥
एवं न पतते गर्भः स च शूलः प्रशाम्यति । षष्ठे मासि तु गर्भस्य चलता जायते यदा ॥

गैरिका गोमयं पयसा कृष्णा मृत्तना तथैव च । एतेषां साधितं प्राज्ञाभिज्ञा चामुतं तदा ॥
पेयं शीतं परं साकं सितया चन्दनेन च । सप्तमे मासि गर्भस्य चलनं जायते यदा ॥

उशीरं गोक्षुरानौ समङ्गा नागकेशरम् । सपद्मकं समधुना पाययेच्च विचक्षणः ॥
अष्टमे मासि चलनं गर्भजं यदि जायते । लोषमणिधिकाचूर्णं मधुना पयसा भिन्ने ॥ (यो० २० स्त्रीरोग चि०)

Powdered *lodhra* and *māgadhikā* mixed with honey and milk should be prescribed for *garbha calana* during eighth month.

गर्भपात प्रतिषेधार्थं वराणबन्ध (Varanabandha for preventing abortion)

महर्षि कारश्य ने कल्पस्थान के रेवती कल्पाध्याय के अंत में गर्भिणी स्त्री को वराणबन्ध बाँधने का विधान बताया है । यह वराणबन्ध मंत्र-चिकित्सा का ही एक रूप है, इसकी उपादेयता के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है, लोक में भी यह अधिक प्रचलित नहीं है ।

Kāśyapa has prescribed a type of *mantra* treatment for preventing abortion. It is difficult to explain its utility as it is not in practice.

वराणबन्ध का काल (Period of varanabandha)

बन्धो हि गर्भिण्याः क्षयति प्राणमृत्तमासात्, अत ऊर्ध्वं प्रतिषेधस्तस्यान्य ॥ (का० सं० कल्प० ६/८०)

यह बन्ध गर्भिणी को आठवें मास के पूर्व ही बाँधना चाहिए । आठवें मास के पश्चात् इसको प्रयोग करने का निषेध है ।

It should be applied before eighth month. After this month it is contraindicated.

विमर्श (Comments)

चूँकि वराणबन्ध का मुख्य उद्देश्य गर्भपात का निवारण है एवं नवम मास का एक भी दिन हो जाने पर प्रसवकाल माना जाता है, अतः आठवें मास के बाद वराणबन्ध का निषेध यथोचित ही है ।

Since the purpose of this treatment is prevention of abortion or premature delivery, hence its contraindication after eighth month is justified.

वराणबन्ध की उपादेयता (Benefits of varanabandha)

महर्षि कारश्य ने वराणबन्ध का वर्णन करते समय बन्धन विधि में मातंगी विद्या के प्रयोग का विधान बताया है । जिस विद्या की उपादेयता का वर्णन करते हुए इसे स्वस्ति एवं शांतिकर, सन्तान को उत्पन्न करने वाली, गर्भ का बन्धन करने वाली, विमल, अमोघ, कल्याण करने वाली बताया है तथा लिखा है कि ऋतुमती स्त्री को सुनाये जाने पर वह गर्भवती हो जाती है, गर्भवती स्त्री को सुनाए जाने पर वह पुत्र वाली हो जाती है, प्रसव-कष्ट से पीड़ित को सुनाये जाने पर उसे शीघ्र प्रसव हो जाता है तथा जिसके पुत्र मर जाते हैं उसे सुनाये जाने पर उसके पुत्र जीवित रहते हैं^१ । इन लाभों के अतिरिक्त इस विद्या को भय एवं शत्रु का नाशक आदि भी बताया है, जो अप्रासङ्गिक होने के कारण यहाँ पर वर्णन नहीं किए जा रहे ।

सम्पूर्ण वराणबन्ध की उपादेयता के बारे में लिखा है कि इससे स्त्री को सन्तान की प्राप्ति होती है, उसे सर्वभूतों का भय नहीं रहता । वह जीवितपुत्र, भाग्यवती तथा विधवा न होने वाली होती है, इसके बन्धन से सन्तान न हो ऐसा हो ही सकता ऐसा महर्षि कारश्य का कथन है^१ ।

१. मातंगी नाम विद्या स्वस्ति कल्पी शांति करी प्रजा करी बन्धनी विमला अमोघ कल्याणी, य इमां शिष्यमुत्पन्तां श्रावयते गर्भिणी भवति । य इमां गर्भिणीं श्रावयते पुत्रवती भवति । य इमां कृच्छ्रसत्वां श्रावयत्यशु मुच्यते । य इमां शिष्यमाणुष्यां श्रावयति जीवत्युता भवति । (का० सं० क० ६/८०)

२. बद्धे चैनो सा ह्यस्याः प्रजाः प्रयच्छति । बद्धे प्रतिषेधे प्रजावरणं चद्धं भवति । नास्याः सर्वभूतेभ्यो भयं भवति, आशा समुद्भूते, जीवत्युता सुभागा चाविधवा च भवति । नास्याः प्रजा न भवति त्याह भावन् कश्यपः ।
(का० सं० क० ६/८०)

पूर्वोक्त गोमूत्र को अहुति दे। प्रजा (सन्तान) को इच्छा रखने वाले, पशु को इच्छा रखने वाले तथा आयु को इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त अहुतिर्वा देनी चाहिए।

Pious and fasting physician should apply *varanabandha* to the woman who has reverence, observes righteous virtues and has been fasting for three days. After this *bandha* she should worship the goddess by desired sacrificial offerings, thus the goddess provides her with progeny. For this the woman should take bath during *sambhāra* or *rohini nakshatra*. It should be taken inside the house during night, while during day time secretly amidst the forest is the opinion of persons. The process of bath should be started after protecting her by covering the place from all the sides. Now the physician should besmear with cow-dung and water the altar made in pious place and measuring in size to *gocarna*. The physician after taking bath and wearing new garments and ornaments should sit facing to the east, and quietly stretching his arm should sip the noisiness, frothless, lukewarm water thrice for sacrificial rituals without spitting by the method advocated in *brāhmanas*, then wash his lips twice or thrice (according to some other persons). After this he should touch his both the eyes, ears, nose and anus with (fingers dipped in) water. When the bright sun is visible he should bedew the altar and write the symptoms narrated by the pregnant woman on the bunch of *darbha* which is held alongwith the gold by the pregnant woman; after writing the symptoms he should bedew the bunch of *darbha*, go out and do obeisance to the fire. Afterwards, collecting all the things needed for *yajña* should sanctify these; then holding *kūśas* he should go round the altar from left to right direction, thus, keeping the fire always on the right side. He should now place the idols of *kumāra*, *śaśī* and *viśākhā* made with any one out of gold, silver, *usīra* or *darbha* in front of fire, the *brahmin* of *yajña* in the south and pot of water in the north side. After sanctifying the *ghṛta* with two *darbha* of similar length with intact tips and tied together, he should recite the *mantra* that this is *āyva*, *devabhṛjya*, *reja*, *cakṣu*, *śrotra*, *indriya*, *āyu*, *sarya* and *havi* and pour the *ghṛta* with the help of sacrificial ladle made of *darbhas* for oblation. Now the pregnant woman who has already taken bath, is fasting and wearing white garments and ornaments should be made to sit quietly over a wooden comfortable seat facing northwards, holding two *darbhas*. The pregnant woman should sit calm and quiet. The physician after obtaining the permission of others should offer oblation in the fire daily and after pouring *ghṛta* in the fire offer, oblation reciting *mātaṅgī vidyā*. Reciting this *mātaṅgī vidyā* he should collect eight hundred sticks of each *śamū*, *palāśa* and *aśwathā*, eight hundred white flowers, eight hundred yellow *sarsapa*, *ghṛta*, oil and *vasā* (fat), after stirring all these with honey and *ghṛta* he should put three sticks (one each of *śamū*, *palāśa* and *aśwathā*) together in the fire and at the end of *mantra* should give oblation of *ghṛta*. After repeating this process for eight hundred times, reciting *nudāmaṅgī vidyā* he should put the garland in the neck of the woman made with *lakṣmaṇā*, fruit of *putrañjīva*, *samudrapheṇa*, *kaiṭumbī*, *sarsapa*, *arka* and *śukti* tied together with the wool of animals. By this *nudāmaṅgī vidyā* he should treat the garland, once the garland is treated it is understood that now *prajāvārāna bandha* is applied. Now

1. 7 X 30 X 10 = 2100 Sq. hasta or about 315 Sq. feet. (comm. of KS.)

15 x 15 hasta or arm length. (Apte)

after offering a riṅht sacrifice for oblation he should recite the *śānti mantra* and reperform the oblation and worship the gods; after sending forth these gods, he should pacify the fire by offering sacrifices and bedewing it, worship the *brāhmanas*, saints and persons having sons and longevity by offering donations and garments and then sit quietly. Afterwards he should keep all the articles of oblation either on a four-way crossing or in water (pond or river) or under a *kṣūr vykṣa* (alex yielding tree). Once by this entire process the *prajāvārāna bandha* is applied she definitely gets a progeny, is the opinion of Kaśyapa. After this he should cook *carru* (an oblation prepared with rice, barley and pulse) with milk and give its oblation (in the fire) to god *prajāpati* for seven consecutive days, others opine that instead of *carru* earlier mentioned cow's *ghṛta* should be used. The persons desirous of progeny, animals and longevity should perform these oblations.

गर्भ के कुछ अन्य विकार (Certain other fetal disorders)

(१) गर्भशोष या वाताग्निपन्न गर्भ (*Garbhaśoṣa* or *vātāgnipanna garbha*)

कारण एवं लक्षण (Etiology and clinical features)

आहारमज्जोति यदा न गर्भः, शोषं समाज्जोति परिच्युति वा।

तं स्त्री प्रसूते सुविशेष गर्भं, पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात् ॥ (च० सं० शा० २/१५)

वाताग्निपन्न एव शुष्यति गर्भः। स मातुः कुक्षिं न पूरयति मन्दं स्पन्दते च ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)

यदा तून्मार्गो वातो गर्भस्य रसवाहीनि स्रोतांसि शोषयति तदा वातरोगी हीनो जायते। बहुनि वा वर्षायुदरे तिष्ठति ॥ (अ० सं० शा० २/३७)

जब गर्भ को (उचित) आहार नहीं प्राप्त होता या (गर्भधान होने के बाद भी) स्वाव (योनि से रक्तवाह) होते रहने के कारण गर्भ का शोष हो जाता है, उस वर्षों के बाद भी पुष्ट हुए गर्भ को स्त्री विरकाल के बाद प्रसवित करती है। अन्यत्र वायु के कारण गर्भ में शुष्कता होने का उल्लेख है^१।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि वात से आक्रांत होने पर गर्भ सूख जाता है, तब वह माता की कुक्षि का पूरण नहीं करता तथा मन्द स्पन्दन करता है। टीकाकार डल्हण ने मन्द स्पन्दन का कारण गर्भ के वात से आक्रांत होने के कारण ओज का विरहित होना माना है एवं वृद्ध काश्यप द्वारा वर्णित शुष्क गर्भ के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भ की नाड़ी में रस के वहन न होने या अल्प वहन होने के कारण गर्भ को समय पर भोजन न मिलने से गर्भ बहुत देर में बढ़ता है एवं कुक्षि का अपूर्ण तथा मन्द स्पन्दन आदि लक्षण होते हैं^२।

अष्टांगसंग्रहकार ने भी लगभग महर्षि सुश्रुत सदृश ही लिखा है कि जब उन्मार्गमयी (वेगवरोधादि कारणों से प्रकुपित) वायु गर्भ के रसवाही स्रोतों को सुखा देता है तो वह गर्भ वातरोगी एवं हीन हो जाता है तथा बहुत वर्षों तक उतर में ठहरता है। अष्टाङ्गहृदयकार ने भी वायु के कारण गर्भशोष होने का वर्णन दिया है^३।

महर्षि भेल ने लिखा है कि जब वायु योनि-गत शुक्र को ग्रहण कर लेती है एवं (उसी वायु आक्रांत शुक्र से)

१. च० सं० चि० २८/५, १६ (विकिसान्तरित उद्धृत)।

२. वातरोगेणैव विहतौजस्त्वाद गर्भो मन्दमेव चलति। वृद्धकाश्यपेन शुष्कलक्षणमभिहितं यथा-

"गर्भनाड्यास्त्वहनादल्पत्वाद वा सस्य च। विशेषणायते गर्भस्त्वैवकालभोजनात्। अकुक्षिपूर्णं गर्भस्पन्दनं मन्दमेव च" इति ॥ (सु० सं० शा० १०/५७ को डल्ह० टीका)

३. अ० ह० चि० २१/२१ (पृष्ठ ३६०)

स्त्री को शुद्ध आर्तव (एवं शुक्र) के समन्वय से गर्भ धारण हो जाती है तब यदि खाव (रक्त का) होता है तो गर्भ का नाश हो जाता है उसे बालोदर कहते हैं^१ ।

आचार्य भावमिश्र एवं योगरत्नाकरकार ने बहुत ही संक्षेप में कहा है कि वात से गर्भ शुष्क होने के कारण उदर का पूरण नहीं करता^२ ।

Due to non-availability of proper diet (nourishment) to the fetus or vaginal discharges (bleeding) after conception the fetus suffers from śoṣa (emaciation or dryness). This fetus attains its proper growth or maturity after years and the woman delivers it after years or prolong delay. Vāyu is also said to be a cause for dryness of fetus.

Suśruta opines that due to affliction by vāyu the fetus gets dried up, does not fill properly the mother's abdomen and quivers very slowly. Dalhāṇa elaborating the etiology says that due to effect of vāyu the fetus has absence of ojas. Further quoting Vaidha Kāśyapa writes that the rasa either flows slowly or does not flow in the rasavahānāḍī of fetus thus it develops very slowly.

The upwards moving vāyu dries rasavāhī channels of the fetus, thus it suffers from vāta disorders, becomes emaciated and remains in uterus for years together is the opinion of Vāgbhata I. Vāgbhata II opines that vāyu dries the fetus.

Bhela says that when vāyu situated in yoni gets mixed up with śūkra and conception takes place with the union of healthy ārtava and this vitiated śūkra, then if bleeding occurs, the fetus gets destroyed and this condition is termed as vātoḍara.

Bhāvaprakāśa and Yogaratnakara have followed Suśruta.

चिकित्सा (Treatment)

- (१) रुध्र पदार्थों का त्याग^३ ।
- (२) बृंहणीय औषधि, दुग्ध एवं मांसरस का प्रयोग करें^४ ।
- (३) लीन गर्भ वर्णित चिकित्सा भी करें^५ ।
- (४) गर्भशोष होने पर मधुयष्टी, काशमरी-फल, शारिका एवं शर्करा से शृत दुग्ध देना चाहिए^६ ।
- (५) मांसाहारी प्राणियों के मांसरस में बृंहणीय औषधियाँ एवं स्नेह मिलाकर देना चाहिए^७ ।
- (६) जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं बढ़ रहा है उन्हें क्षीर का प्रयोग करना चाहिए, इससे गर्भ को पुष्टि प्राप्त होती है^८ ।
१. गृह्णीति वायुर्यसं च योनौ शुक्रमुपातः (म) । विभर्ति गर्भं (धर्मि)णी गर्भं शुद्धातवसमन्विता ॥ ६॥
व्यवृते च यदा वाऽसौ तदा गर्भः प्रणश्यति ॥
बालोदरे विन्यस्तहै ॥ ७॥ (धे० सं० शा० ३/६ व ७)
२. गर्भे बालेन संयुञ्जो नोदरं पूरयेद्वि । (धो० प्र० चि० ७०/९७ एवं यो० २० स्त्रीतो० चि०)
३. तस्माद्दुग्ध (शो)णि वर्जयेत् । (धे० सं० शा० ३/७)
४. सा बृंहणीयैः संसिद्धं दुग्धं मांसरसं विभेत् ॥ (धो० प्र० चि० ७०/९७ एवं यो० २० स्त्रीतो० चि०)
५. तं बृंहणीयैः पर्याभिमांसरसैश्चोपचरेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)
६. मांसरसैश्चेति चकायल्लीनप्रतिकारसमुच्चयः ॥ (सु० सं० शा० १०/५७ की डल्ह० टीका)
७. शुष्यति तु गर्भे बालेषु च यष्टमधुकराशयफलशारिकाशर्कराशृतं पयो दद्यात् । मांसात्मांसरसांश्च बृंहणीयस्नेहयुक्तान् ॥
(अ० सं० चि० २३/१२)

है एवं उसमें दृढत्व आता है^१ ।

(७) महर्षि चरक ने लिखा है कि यदि वायु के कारण गर्भ में शुष्कता हो जाय या बालक सूखने लगे तो उसके उपशपन अर्थात् पुष्टि के लिए सित्त, काशमरी एवं मधुक से शृत दुग्ध देना चाहिए^२ ।

- i) Use of dry articles should be avoided.
- ii) *Bryhanṇya* (anabolic) drugs, milk and meat soup should be used.
- iii) Treatment prescribed for *līna-garbha* can be used.
- iv) Milk treated with *mādhuvāṣṭī*, fruit of *kāśmarī*, with *śāririvā* and mixed with sugar should be prescribed.
- v) Meat-soup of carnivorous animals mixed with *bryhanṇya* drugs and fat should be given.
- vi) Milk should be prescribed as it provides nourishment and stability to the fetus.
- vii) Charaka has mentioned that if due to vitiation of vāyu, the fetus gets dried or child gets emaciated then for growth and development of this, the milk medicated with *sitā*, *kāśmarī* and *mādhuka* should be prescribed.

विमर्श (Comments)

गर्भशोष गर्भाशयान्तर स्थित गर्भ की अल्पवृद्धि का द्योतक है ।

Garbhaśoṣa refers to intrauterine growth retardation of fetus.

(२) उपाविष्टक गर्भ (Upaviṣṭaka garbha)

निदान, सम्प्राप्ति एवं सामान्य लक्षण (*Etiopathogenesis and clinical features*)

यस्याः पुनरुज्जातीक्ष्णोपयोगादगर्भस्या महति संजातसारे गर्भे पुष्पदर्शनं स्यादन्यो वा योनिस्त्रावस्तथा गर्भो वृद्धिं न प्राप्नोति निःस्तुत्वात्, स कालमवतिष्ठेऽतिमात्रं, तमुपविष्टकमित्वाचक्षते केचित् ।

(च० सं० शा० ८/२६)

यस्याः पुनर्महति जातसारे गर्भे वर्ज्यानामवर्जनात्पुष्पदर्शनं स्यादन्यद्वा योनिस्त्रावणम् । ततो नाड्यां दोषैः कुल्यायाभिच तृणपत्रादिभिः प्रतिच्छन्नायां रसस्यासम्पन्नवहनादगर्भो वृद्धिमन्वानुवृत्तियशस्यपुष्टयति वा ॥

तत्र यस्याः कदाचिकत्कर्तव्यं (कदाचिदतिव-शु० पा०) परित्वावावलयौ च दृश्यते सततं च गर्भः प्रासात्परिमाणदपरिहीयमान एव स्फुरति न च कुक्षिविषयते तमुपविष्टकमित्वाचक्षते ॥ (अ० सं० शा० ४/११, १२)

सञ्जातसारे महति गर्भे योनिपरिस्त्रावत् । वृद्धिमन्प्रानुवर्त्त गर्भः कोष्ठे तिष्ठति सस्फुरः ॥ १४॥

उपविष्टकमाहृत्सं, वर्धते तेन नोदरम् ॥ (अ० ह० शा० २/१४ व १५)

जब बढ़ा एवं संजातसार गर्भ हो जाने के बाद गर्भिणी द्वारा उष्ण, तीक्ष्ण आदि द्रव्यों के प्रयोग के कारण पुष्प-

१. गर्भश्च यस्या न विवर्धते च ॥ ८४॥

पुष्टिर्दृढत्वं तपते च गर्भो ॥ ८७॥ (का० सं० कल्पा० ७)

२. (अ) गर्भे शुके तु बालेन बालानां चापि शुष्यताम् ॥ १५॥

सिताकारमधुमधुकैर्हितमुत्थापने पयः ॥ १६॥ (उत्थापने पुष्टिजनने-चक्र०) (च० सं० चि० २८)

(अ) गर्भे च विशुष्यताम् । मधुकैः सिद्ध ॥ (च० सं० सद्गुश) (अ० ह० चि० २१/२१, २२)

दुःख (रजःस्व) या अन्य किसी भी प्रकार का साध होने लगता है तो निःसृति के कारण गर्भ की वृद्धि नहीं होती, वह गर्भ गर्भाशय में अतिकाल तक बना रहता है उसे उपाधिक कहते हैं।

[illegible]

पुनश्च उपविष्टक के विशिष्ट कारणां का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब गर्भवती स्त्री को थोड़ा थोड़ा सा परनु निरन्तर रक्तस्राव होता है तब वह गर्भ अपने प्रास्य परिमाण से न घटता हुआ अर्थात् उतना बड़ा ही बना रहता हुआ स्मरण करता है। कीक्ष का वर्धन नहीं होता उसे उपविष्टक गर्भ कहते हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि संज्ञातसार एवं गर्भ के वढ़ते हुए होने के बाद यदि योनि से स्राव (रक्तस्राव) होता है तब वृद्धि को प्राप्त न होता हुआ, (परन्तु) स्मरण करता हुआ गर्भ कोष्ठ में स्थित रहता है, उमे उपविष्ट कहते हैं, इसमें उदर की भी वृद्धि नहीं होती। टीकाकार अरुणदत्त ने संज्ञातसार अथवा बलवान् गर्भ की वृद्धि होने के बाद (अर्थात् गर्भावै या छठे मास के बाद) इस अवस्था के होने का निर्देश किया है तथा लिखा है कि योनि से अधिकतर तो रक्त ही निकलता है परन्तु कभी-कभी अन्य प्रकार के भी स्राव होते हैं। परिस्वाय के कारण वृद्धि को न प्राप्त होता हुआ गर्भ कोष्ठ या गर्भाधार या गर्भाशय में ठहरता है। योनि से स्राव के कारण प्रकुचित वायु पित्त एवं श्लेष्मा को लेकर गर्भ की गम्यता नाही को आच्छादित कर गर्भ का पोषण नहीं होने देती^१।

After some development and attainment of *sāra* (after fourth month) by the fetus if bleeding per vagina or other types of vaginal discharges occur due to use of pungent and hot articles by the pregnant woman, then the fetus does not grow properly due to these discharges, and stays in the uterus for a very long time. This condition is termed as *upavistāka*.

Vāgbhāta I mentioning the causes of *upavīṣṭaka* and *upāśuṣka* both together writes that after attainment of *sra* by the fetus if woman uses contraindicated articles, bleeding per vaginum or other vaginal discharges start. *Vīna* aggravated due to this bleeding withholding *pīṭta* and *śleṣmā* compresses the *rasavahā nāḍī* of the fetus. Because of this obstruction to *rasavahā nāḍī* causing improper flow of *rasa*, the fetus does not develop properly and becomes *upavīṣṭaka* or *upāśuṣka*, in the same way as the paddy does not grow properly if the water does not reach the field due to obstruction with leaves and grass etc. to its flow

१.सञ्ज्ञातसातो-बलवान् गर्भः, तस्मिन् । तथा, महति प्रवृद्धे साति ।.....। परित्यज्य इति च सामान्यं नित्यं शास्त्रे

कदाचिद्रक्तरूपः कदाचिद्वदन्दाशुशोभि गर्भास्तवति । परितवात्त्वा कारणत्वा वृद्धिप्रधानुवत् कोष्ठ एव-गर्भाधार एव
कदाचिद्रक्तरूपः कदाचिद्वदन्दाशुशोभि गर्भास्तवति । परितवात्त्वा कारणत्वा वृद्धिप्रधानुवत् कोष्ठ एव-गर्भाधार एव

तद्विनाशः । नानाभावात्सक्येन च । तदुक्तं ।
 तद्विनाशः । नानाभावात्सक्येन च । तदुक्तं ।

(अ० ह० शा० २/१४ व १५ की अरुण० टीका)

in the supply-channels. Further giving specific etiology of *uparīṣṭaka* he writes that when the woman gets scanty but continuous bleeding per vaginam, then the fetus without decreasing in its size continues the quivering. *Kukṣi* (uterus) does not increase in size. Identical is the opinion of Vāgbhaṭa II. Aruṇadatta specifying the period of disease says that it occurs when the fetus has become *balawāna* (strong i. e. 5th or 6th month).

(३) नागोदर या उपशुष्क गर्भ (Nāgodara or upaśuṣka garbha)

कारण, सम्प्राप्ति एवं लक्षण (Etiopathogenesis and clinical features)

उपवासव्रतकर्मरायाः पुनः कदाहारायाः स्नेहद्वेषिण्या वातप्रकोपणोक्तान्येत्यमानाया गर्भो वृद्धिं न प्राप्नोति उपवासव्रतकर्मरायाः पुनः कदाहारायाः स्नेहद्वेषिण्या वातप्रकोपणोक्तान्येत्यमानाया गर्भो वृद्धिं न प्राप्नोति परिशुक्लत्वात्; स चापि कालमवतिष्ठतेऽतिमात्रम्, अस्यन्दनश्च भवति, तं तु नागोदरमित्याक्षते ॥

(च० सं० शा० ८/२६)

शुक्रशणितं वायुाभिपप्रभमवक्रान्तीवभाष्पापदयुदम् । तं कदाचिद् यद्दृच्छ्योपशान्तं नैमेषापहृतीमिति भाषन्ते । तमेव कदाचिद् प्रलीयमानं नागोदरमित्याहुः ॥ (सु० सं० शां० १०/५७)

यस्यापुनर्महति वृद्धिमानाजुबुधविशत्युपशुष्यति वा ॥ (उपविष्टकान्तगत वर्णित)

यदा तु प्रतिभासमातत्वं प्रत्यहं वा परित्तवणं नादत्त्वं च तथा परिहीयमाणो गभीश्चिरात्किञ्चित्स्पन्दते । कुक्षिश्च वृद्धोऽपि परिहीयते तदुपशुष्ककं नागोदरं च ॥ (अ० सं० शा० ४/१९ एवं १३)

शोकोपवासरूक्षाद्वैरथवा
योन्यतिस्रवात् ॥ १५ ॥

वाते कुब्धे कृशः कृष्येद्गर्भो 'नागोदरं' तु तम् ॥

उदरं वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुराणं चिरात् ॥ १६ ॥ (अ० ह० श्रा० २/१५ व १६)

उपवास एवं व्रत परायाण, कुतिसल भोजन करने वाली, स्नेहद्वेषिणी (भोजन एवं पान में स्नेह द्रव्यों का प्रयोग न करने वाली) तथा अन्य बात प्रकोपक (आहार विहार) का सेवन करने वाली स्त्री का गर्भ शुष्क हो जाने के कारण वृद्धि को नहीं प्राप्त होता, वह (उदर में) अतिकाल तक अधृति बहुत देर तक ठहरता है तथा स्पन्दन नहीं होता इसे नागोदर कहते हैं ।

यद्यपि महर्षि चरक ने नागोदर से पीड़ित होने वाले गर्भावस्था के काल का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया परन्तु उपाधिक के बाद वर्णन होने के कारण ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि यह भी गर्म के संज्ञातसार होने के बाद की ही व्याधि है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि वायु से पीड़ित शुक्र एवं शोणित जीवात्मा की अवक्रान्ति होने के बाद उदर का आभ्रान कर देते हैं। वह कटादिष्ट अपने आप शान्त हो जाने पर नैमिषोषणहृत कहलाता है तथा कभी प्रलीयमान होने पर 'नानोदर' कहलाता है। टीकाकार इत्थण ने इसे असंवात अंग की अवस्था अर्थात् तीसे मास से पूर्व की अवस्था का विकार माना है तथा लिखा है कि यह उदर में अकुचित अर्थात् बिना सड़ी हुई अवस्था में रहता है तथा वात के प्रकोप के कारण बार-बार स्रोतों में प्रकीर्तियमान होता है अर्थात् अल्प या छोटा होता जाता है।

अष्टांगसंहकार ने उषुषु के विशिष्ट निदान में लिखा है कि जब (गर्भवती स्त्री में) अर्ताव (रक्त) प्रतिमास या प्रतिदिन अनल्प (अधिक) मात्रा में स्रवित होता रहता है, तब पहीर्यमाण (प्रमाण) में घटता हुआ) गर्भ बहुत देर से एवं

१. शुक्रशीर्षितामिति वचनादसञ्ज्ञाताङ्गप्रत्यङ्गमेव, चाप्युपनिषत्प्रपञ्चं चापुनरपहङ्गं, अवक्रान्तजीवं जीवन्गोपातम्, अतएवाकुक्षितमव-
तिष्ठते ।। तमेव वाताग्निप्रपञ्चो, पुनः पुनरप्यावृत्त्या प्रवर्तितमपानतन्त्रिभूतत्वं नागोदरमिति ब्रुवते ॥

(सु. सं. शां १०/५७ की डल्हं टीका)

शोड़ा-शोड़ा स्पन्दन करता है। कुक्षि (उदर) की वृद्धि भी घटती जाती है तब उसे उपशुष्क या नागोदर कहते हैं।

अष्टांगहृदयकार ने लिखा है कि शोक, उपवास, रक्ष (अन्नपानादि) आदि के प्रयोग अथवा योनि से (रक्त के) अतिस्त्राव होने से कुछ वायु गर्भ को कुश करके उसे नष्ट कर देता है या सुखा देता है^१ उसे नागोदर कहते हैं। इसमें उदर की वृद्धि भी घटती है तथा देर से स्फुरण होता है।

महर्षि भेल ने संक्षेप में लिखा है कि शिराओं के मुखों (स्रोतस) की वृद्धि के कारण जब गर्भ को रस सामान्य रूप से नहीं मिलता तो वह (रस के न मिलने के कारण पूर्ण रूपेण न बढ़ा हुआ गर्भ) असम्पूर्ण होने के कारण नाग (हाथी के गर्भ) की तरह ज्यों तक (गर्भाशय) में रहता है^२। पुनश्च लिखा है कि जातसार (गर्भ के चौथे महीने के बाद) होने के बाद यदि योनि से पुष्प (रक्त) का स्त्राव होता है तब उसे स्त्री में रक्त के गिरने के कारण न बढ़ा हुआ गर्भ परिशुष्क मात्र होकर ठहरता है अर्थात् सूखा हुआ गर्भ सका रहता है^३।

आचार्य भवामिश्र ने लिखा है कि शुक्रार्तव से बना हुआ अजातारु (अंग-प्रत्यंग न बना हुआ), वायु से पीड़ित होने के कारण सूखा हुआ, जीवात्मा के द्वारा परित्यक्त गर्भ कठिन होकर उदर में ठहरता है। शुक्र एवं रक्त को नष्ट करने या सुखाने वाला वह वायु कभी-कभी पेट में आभ्यन कर देता है, कुछ काल बाद आभ्यन अपने आप शान्त हो जाता है तब लोक में नैमेयेय ने गर्भ को हरण कर लिया इस प्रकार कहा जाता है। वह कभी अल्प प्रवृत्ति (योनिमार्ग) से रक्त को अल्प प्रवृत्ति के कारण लघु अर्थात् अपने सामान्य आकार से छोटा होकर उदर में ठहरता है, इस गर्भ को लोक में 'नागोदर' कहते हैं।^४

योरात्माकारकार ने आचार्य भवामिश्र के समान ही वर्णन करते हुए लिखा है कि शुक्रार्तव से बना हुआ अजात अंग-प्रत्यंग (अर्थात् दो या तीन माह का गर्भ) वाला, वायु से पीड़ित गर्भ जीवात्मा के द्वारा परित्यक्त होकर क्वाथित होकर, अर्थात् सड़कर (गर्भाशय में) ठहरता है। शुक्र एवं आर्तव को आर्द्र करता हुआ वायु उदर में आभ्यन कारक होता है, कभी-कभी वह आभ्यन स्वयं ही शान्त हो जाता है, तब लोक में नैमेयेय ने गर्भ हर लिया ऐसा कहते हैं। वहीं लोक में नागोदर गर्भ भी कहा जाता है।

The woman who often observes fasts, eats stale food, does not take fat and uses other vāta vitiating articles, her fetus gets desiccated and does not grow. This fetus remains in the uterus for a very long time and does not quiver. This entity is termed as *nāgōdara*.

Suśruta writes that *śukra* and *śonita* afflicted by *vāyu* after descend of *jīvātmā* produce distension of abdomen. When this distension disappears it is said that the fetus has

१. पाठ भेद में "कुषेत्" के स्थान पर "शुषेत्" पाठ है जो अधिक युक्तिसंगत है। अथवा "कुषेत्" के स्थान पर "कुषेत" कर देने से भी कृशता या शुष्कता का अर्थ निकल आता है।

२. नाजोति च यदा गर्भो रसं दृष्टैः स्मिरमुद्धैः। असंपूर्णां वसं (न) नास्तदा वर्णाणि तिष्ठति ॥ (धे० सं० शा० ३/१२)

३. त(य)स्यास्तु खलु योनिः(ः) जातसरे पुष्पमाश्रय(स्व)ति तस्याः पतति नवायित्य(प्यति)कालं जावतिष्ठते गर्भः परिशुष्कमात्रं इति ॥ (धे० सं० शा० ८/५)

४. शुक्रार्तवमजातारु संशुष्कं मरुताऽर्दितम्। तत्कं जीवेन ततस्मात्कठिनं जावतिष्ठते ॥ ९८॥

शुक्रार्तवार्द्रको वायुहृदाभ्यनकृद् भवेत्। कलाचिच्चेतदाभ्यनं स्वमेव प्रशाम्यति ॥ ९९॥

नैमेयेयं गर्भोऽयं हृते लोकव्यतिस्तदा। स एवातप्रवृत्त्या चेन्नपुर्णतयावतिष्ठते ॥ १००॥

तदा स गर्भो भवति लोकं नागोदराद्वयः ॥ १०१॥ (धा० प्र० चि० ७०)

५. शुक्रार्तवमजातारुं प्रत्यङ्गं मारुतादितम्। तत्कं जीवेन ततस्मात्कठिनं जावतिष्ठते ॥ शुक्रार्तवार्द्रको वायुहृदाभ्यनकृद् भवेत्। कलाचिच्चेतदाभ्यनं स्वमेवेवाऽप्येतत्तम् ॥ नैमेयेयं गर्भोऽयं हृते लोकव्यतिस्तदा। स चापि गर्भो भवति लोकं नागोदराद्वयः ॥ (यो० १० स्त्री० चि०)

been taken away by *nāgāmayat*; however, sometimes if it is re-absorbed then it is called *nāgōdara*, Dhallana says that the disease occurs before three months of pregnancy and embryo remains there without decomposition, because of its dissolution in the *strotasas* its size decreases.

Vāgbhata I giving specific etiology (general described under *upavīṣṭaka*) of *upavīṣṭaka* says that when the pregnant woman gets excessive bleeding either daily or monthly, then the fetus decreases in size and quivers very slightly, size of abdomen also decreases. This entity is called *upavīṣṭaka* or *nāgōdara*.

Vāgbhata II says that either due to grief, fasting and use of dry articles or due to excessive bleeding the vitiated *vāyu* producing emaciation of fetus destroys it or desiccates it. This is called *nāgōdara*. In this condition size of abdomen also decreases and quivering of fetus is delayed.

Bhela says that fetus does not get proper *rasa* due to vitiation of orifices of *sirās*. This under-developed fetus remains in the uterus for years just like the fetus of elephant. Because of the bleeding per vagina occurring after the fetus has become *jāṭāvara* (after 4th month of pregnancy) it does not develop properly. Gets desiccated and remains in the uterus.

Bhāvaprakāśa and Yogaratnakara have given similar description as written by Suśruta.

उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ में जातिधिक्य होने पर लक्षण (Clinical features of *upavīṣṭaka* and *upavīṣṭaka garbha* having predominance of *vāyu*)

तत्र जातेनोपविष्टकोपशुष्कयोर्वायुः प्रतिहृत्यते सशब्दं फेनितं विच्छिन्नं शकृदुपवेश्यते मूत्रमुपशुष्यते कटीपृष्ठहृदये वेदना नृप्मा निद्रानाशोऽभीष्टां प्रतिशयायः शुष्ककासः सादः क्ष्वेतते इव कर्णौ तुधते इव शङ्खौ पिथीलिकाभिरिव संमुच्यते शरीरं परीकृन्तन्निव वायुभ्रमति कुक्षौ तम इव प्रवेश्यते दृःखेनात्रस्य जरणमहर्हः परिसिनिः स्फुरतिविवर्णपरुषत्वत्तं च भवति ॥ (अ० सं० शा० ४/१५)

उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ में (उपविष्टक या उपशुष्कावस्था के बाद भी वात प्रकोपक या अन्य अपथ्य के सेवन से) वायु की अधिकता होने पर वह वायु उस स्त्री को आक्रान्त करती है, इससे उस स्त्री को शब्द के साथ, फेनदार, फटा हुआ सा (छिछड़ेदार) मल-त्याग, मुत्रावरोध, कटि, पृष्ठ एवं हृदय प्रदेश में वेदना, नृप्मा, निद्रानाश, अभीष्टा या अत्यधिक प्रतिशयाय, शुष्क कास, अंगसाद आदि हो जाते हैं, कर्ण में कण्डु सदृश अनुभूति, शंखप्रदेश में सुई चुभने सदृश वेदना एवं शरीर में पिथीलिका के चलने सदृश अनुभूति होती है। (उदर को) काटती हुई (सी वेदना करती हुई) वायु कुक्षि में घूमती है। तम-प्रवेश सदृश प्रतीति होती है अर्थात् आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है। अन्न का जरण या पाचन कष्ट के साथ होता है। धीरे धीरे (शरीर का) क्षय होता है। त्वचा स्फुरित, विवर्ण एवं पुरुष या कठोर सी हो जाती है।

When *upavīṣṭaka* and *upavīṣṭaka garbha* have predominance of *vāyu* then this aggravaated *vāyu* attacks the pregnant woman, and she passes liquid, fragmented, frothy stool with sound, and suffers from retention of urine, backache and pain in sacral and cardiac regions, yawning, insomnia, severe coryza, dry cough and lassitude of body; feels itching like sensation in ears, pricking (by needles) like pain in temporal region, creeping of ants like sensation all over the body, *vāyu* moves in abdomen producing cutting pain. She feels as if entering in dark place; her food is digested with difficulty, body is gradually emaciated and skin becomes cracked, discoloured and rough.

उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ में पित्त का प्रकोप होने पर लक्षण (Clinical features of upasūṣka and upaviṣṭaka garbha dominated by pitta)

मिनेन ताम्रवर्तितमुपवेशयते धूमकोऽस्तकशब्दोर्ध्वं कुक्षिहृदयदाहः पीतकगोमूत्राभेनमूत्रनखत्वं काली दुर्बलान्तिशयशूला च नासी भवति ॥ (अ० सं० शा० ४/१६)

उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ में पित्त का प्रकोप होने पर उसे (गर्भिणी स्त्री को) ताम्र एवं हरित वर्ण का मल-त्याग, धूम सदृश (गले एवं मुख में पुरझी भास हुआ सा) प्रतीति, अम्ल-वर्द्धि, मूच्छा, कुक्षि तथा हृदय प्रदेश में दाह, नेत्र, मूत्र एवं नख के वर्ण का पीले या रक्तवर्ण या गोमूत्र के सदृश होना, त्वचा का कालापन, दुर्बलता तथा नित्यप्रति शूल आदि लक्षण हो जाते हैं।

In vitiation of pitta during both these conditions woman passes coppery or green stool, feels as if smoke is filling her mouth and throat, suffers from vomiting of acidic taste, unconsciousness, burning sensation over abdomen and cardiac region, her eyes, nails and urine become yellow, red or like cow's urine in colour. blackening of skin, weakness and continuous pain also develop.

उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ में श्लेष्मा का प्रकोप होने पर लक्षण (Clinical features of upasūṣka and upaviṣṭaka garbha dominated by śleṣmā)

श्लेष्माणामधुरास्यत्वमुक्तेः श्लेष्मोदमनं भक्तद्वेष्टः श्वेतहस्तापादोन्नता कासः श्वासश्च ॥ (अ० सं० शा० ४/१७)

उपशुष्क एवं उपविष्टक में श्लेष्माधिक्य होने पर मुख में मधुरता, उक्तेः श्वेतहस्तापादोन्नता कासः श्वासश्च का वमन, खाने से द्वेष या भोजन में अस्ति, श्वास श्वेत एवं नेत्रों की श्वेतता, कास तथा श्वास आदि लक्षण होते हैं।

When both these conditions have vitiation of śleṣmā, then the woman suffers from sweet taste of mouth, nausea, vomiting containing mucus, dislike for food, whiteness of extremities and eyes, cough and dyspnoea etc.

उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ का प्रसव काल (Time of delivery of upasūṣka and upaviṣṭaka garbha)

तौ तु मातुलहारातेजसाऽत्येनायामानौ यदा पुष्टौ स्यातां केशदशनादिपुक्तौ तदा वर्षाणोरपि प्रमदा प्रसूयत एव ॥ (अ० सं० शा० ४/१४)

वे दोनों (उपविष्टक एवं उपशुष्क) माता के आहार के तेज (अग्नि) से धीरे धीरे बढ़ते हुए जब पुष्ट होते हैं तो केश, दशनादि युक्त उन्हें स्त्री वर्णों के बाद भी प्रसूतित करती है। टीकाकार इन्द्र का मत है कि अधिक दिन तक गर्भाशय में रहने के कारण गर्भ के केश, दशन आदि निकल आते हैं।

महर्षि चक्र ने इन दोनों के ही प्रसव-काल की कोई निश्चित मर्यादा नहीं बताई, पर उपविष्टक के लिए "कालातीति स्थायिनि" अर्थात् "सामान्य प्रसव-काल के बीत जाने पर भी गर्भाशय में ही स्थित रहना" आदि वर्णन कर विलम्बित प्रसव स्थिति की ओर ही इंगित किया है।

महर्षि भेल का कथन है कि माता के आहार-रस से पोषित होकर वह गर्भ जब भी सम्पूर्ण गात्र का हो जाता है, तभी स्त्री की कुक्षि से उसकी विद्युति होकर उसका प्रसव-काल हो जाता है^१, अर्थात् सम्पूर्णज्ञाता को प्राप्त होकर गर्भ

१. तौ चोपविष्टकोपशुष्कौ तदाकेशदशनादिपुक्तौ बहुभिरपि वर्षैः प्रमदा प्रसूयेत ॥ (अ० सं० शा० ४/१४ की इन्द्र टीका)

२. सम्पूर्णान्नो भवति यदा स रसमावर्ततः । तदा प्रसीत्यथाकालं (तं) गर्भः स्त्रीकुक्षिविद्युतिः ॥ (अ० सं० शा० ३/१३)

प्रसूतित होता है।

Both these develop very slowly by the fire of maternal diet. When these attain proper development or maturity then are delivered, may be even after years. Because of prolong intra-uterine stay hair and teeth also grow before birth.

Caraka without specifying any period says that these have prolong intrauterine stay. Bhela opines that delivery depends upon maturity of fetus, delivery takes place only when fetus is fully mature.

उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ-चिकित्सा (Treatment of upasūṣka and upaviṣṭaka garbha)

उपशुष्क या नागोदर की विशिष्ट चिकित्सा (Specific treatment of upasūṣka or nāgōdara)

- (१) महर्षि सुश्रुत ने लीन गर्भ सदृश चिकित्सा का विधान बताया है^१। जिसका वर्णन लीन गर्भान्तर्गत किया जायगा।
- (२) आचार्य भावमिश्र एवं योगरत्नाकर ने धान्य कुट्टन ही इसकी मुख्य चिकित्सा बताई है^२।
- i) Suśruta says that treatment prescribed for lina garbha should be used in this condition also.
- ii) Bhāvanīśra and Yogaratnākara opine that to pestle the paddy is its main treatment.

उपविष्टक तथा उपशुष्क गर्भ की सामान्य चिकित्सा (General treatment of upasūṣka and upaviṣṭaka garbha both together)

- (१) इन दोनों में (उपविष्टक या उपशुष्क में) भूताधिकार में वर्णित घृत^१ यथा कचाघृत, गुणाज्वलितघृत, महापैश्याचिक घृत तथा जीवनीय-वृंहणीय एवं मधुर तथा वातहर औषधियों से सिद्ध घृत^{२,३}, क्षीर मांसस^४ तथा आमार्भ^{५,६,७} (पूण या आण्डे) का अथवा उपर्युक्त (जीवनीय, वृंहणीय, मधुर एवं वातहर) औषधियों से सिद्ध क्षीर या मांसस का प्रयोग करवाना चाहिए^८। ये सभी प्रयोग गर्भ की वृद्धि करने वाले होते हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है कि जो द्रव्य वातघ्न, वृंहण एवं मधुर एक साथ हों यथा द्राक्षा एवं शर्करा आदि उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए^९। वातघ्न एवं वृंहण एवं मधुर इस प्रकार अर्थ नहीं करना चाहिए^{१०}।

- (२) भोजन के साथ भी उपर्युक्त घृत आदि का प्रयोग करना चाहिए^{११}।
- (३) भोजन आदि से तृप्त होकर बार-बार यान, वाहन आदि का प्रयोग तथा श्लेष्मण^{१२,१३} एवं मार्जन, जृम्भण आदि का प्रयोग करना चाहिए^{१४}।

चरकसंहिता के पाठ्येद में एवं टीकाकार चक्रपाणि ने अर्थ करते पर "सुभिश्चायाः" के स्थान में "सुबुध्यायाः" लिखा है उस समय इस शब्द को न० २ के वर्णन के साथ मिलकर 'भूख लगने पर घृत आदि का प्रयोग' यह समझना होगा^१। टीकाकार इन्द्र ने 'सुभिश्चा' का 'तृप्त' अर्थ करते हुए अपवर्जन अर्थात् दानादि देने के विधान का वर्णन दिया है^२।

१. तत्रापि लीनवत् प्रतीकारः ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)

२. धान्यकुट्टमुखा स्याच्चिकित्सा तूपयोपि ॥ (भा० प्र० वि० ७०/१०१ एवं यो० १० स्त्रीरोगचिकित्सा)

नोट- उपविष्टक तथा उपशुष्क गर्भ की सामान्य चिकित्सा के संदर्भ पृष्ठ सं० ३६८ पर देखें।

- (४) टीकाकार अरुणदत्त ने उपविष्टक एवं नागोर में भी स्त्री को बार बार प्रसन्न करने को लिखा है इससे गर्भ की वृद्धि होती है^१।
- i) In both these conditions *ghrita*s prescribed to treat affliction of *bhūta*s i.e. *vacat-ghrita*, *guguluvādi ghrita*, *mahāpāisācika ghrita* or the *ghrita* treated with the *jīvanīya* (capable of increasing longevity), *vṛnīkārīya* (anabolic), *madhura* (sweet) and *vātahara* (capable of suppressing the *vāta*) drugs; milk and meat soup with or without treating with above *jīvanīya* etc. drugs and egg or embryo should be prescribed. All these things enhance the fetal growth and development. Arunadatta opines that the drugs possessing *vātahara*, *vṛnīkārīya* and *madhura* all the qualities together like *drākṣa* and sugar should only be prescribed.
- ii) Above *ghritas* should also be used with diet.
- iii) After having taken satiating food, she should travel repeatedly by vehicles, should do frequent riding, agitating activities, yawning and use cleansing articles. Indu says that she should also offer donation.
- iv) Arunadatta opines that she should be made cheerful repeatedly which helps in development of fetus.

उपविष्टक या उपयुक्त गर्भ में विभिन्न दोषों का प्रकोप होने पर चिकित्सा (Treatment of upaviṣṭaka and upaviṣṭaka garbha having predominance of specific dosas)

(१) वाताधिक्य में चिकित्सा (Treatment in dominance of vāyu)

वाताधिक्य में विशेष रूप से सैष्य मिले दुग्ध की बरसि देकर, शीतल जल से स्नान की हुई स्त्री को शालिधान्य का भात खाने को दे। तत्पश्चात् विद्यादिगण से सिद्ध घृत की अनुवासन बरसि दें। निवात का सेवन अथवा वायु रहित

१. नार्योस्तयोरभयोरपि चिकित्सितविशेषमुदरेश्यामः-भौतिकजीवनीयवृणीयमधुतवातरसिद्धानां सर्पिषां पयसामागर्भाणां चोपयोगो गर्भवृद्धिकरः; तथा संभोजनमेतैव सिद्धेऽथ घृतादिभिः सुभिक्षायाः, अभीक्ष्णं यानवाहनापमर्जनीयवृन्मपीर-पणदन्तमिति ॥ (भौतिक भूतपणवाहितं चचागुणुत्पादिः किंवा महत्पैशाचिकं घृतं वक्ष्यमाणं द्रव्यम्। सुभिक्षाया इति सुबुधुक्षयाः-चक्र०) (च० सं० शा० ८/२९)
२. (अ) तत्पौर्वातनीयवृणीयमधुतयैषधिसिद्धानां सर्पिषामुपयोगः। तथा पयसां रसानामागर्भाणां च गर्भवृद्धिकरः। तथा सम्भोजनमेतैव च घृतादिभिः। सुभिक्षाया अभीक्ष्णं यानवाहनादिभिः शोभणमर्जनीयमधुतयैषधिरपणदन्तम् ॥ (सुभिक्षायास्तस्याया गर्भिण्या यानवाहनादिभिरपणदन्तयुक्तकाः अपयजनम् दानम् इति-इन्द्र) (अ० सं० शा० ४/१८) (आ)आमार्गैर्गर्भः। (अ० सं० सू० १९/१४)
३. तयोर्वृंहणवातन्मधुद्रव्यसंस्कृतैः। घृतक्षीरसैस्सुतिरामार्गार्थं जादयेत् ॥ १७॥
तैरेव च सुभिक्षायाः क्षीरणं यानवाहनेः ॥ १८॥ (अ० ह० शा० २)
४.वृंहणानि च तानि वातजानि च मधुराणि च एवं भूतानि यात्रि द्रव्याणि द्राक्षशर्करादीनि, न तु व्यस्तानि वृंहणानि वातजानि मधुराणि च ॥ (अ० ह० शा० २/१७ की अरुणदत्त टीका)
५. एतां गर्भिणीं उपविष्टकनागोदरानाख्यार्थोदरस्यो हर्षयेत्॥ (अ० ह० शा० २/२० की अरुण० टीका)

गर्भ-व्यापद

(हवा के झोंके आने से रहित) स्थान में रहें^१।

The woman after being given enema of milk mixed with rock salt followed by bath with cold water, should be given cooked *sāli* rice for eating. After this food an *amavāsana* (nutritive) enema prepared with drugs of *vidaryadi* group mixed with *ghrita* should be given. The woman should live in a place sheltered from the wind.

(आ) पिताधिक्य में चिकित्सा (Treatment in dominance of pitta)

- (१) मधुक, विटरी के निर्वृह (खरस या क्वाथ) से सिद्ध दुग्ध पान करें^१।
- (२) उपविष्टक के विवर्धन तथा उपयुक्त के वृंहण के लिए तीन मोटी गुर्गी (का मांस) तथा एक आड़क छिलके रहित माष लेकर दुग्ध एवं जल के साथ उदूखल में कूट कर उसके (कूट कर निचोड़कर निकाले गये) रस तथा सर्पि के साथ तीतर, कपिजल या अन्य इसी भाँति के (पक्षी के) मांसरस को सिद्ध करके पीने को दें^२।
- (३) अजा-मर्गि, अजा-क्षीर एवं जीवनीय गण के द्रव्यों से साधित यवागू का प्रयोग करयें^३।
- (४) पयस्या, दोनों काकोली तथा सुनिषण्णक के कल्क से दूध के साथ घृत पाक करें। इसे प्रातःकाल क्षीर के अनुपान के साथ अथवा आमार्ग (शूण स्थित गर्भ अथवा अण्डा) के रस के साथ सेवन करें; अथवा उर्त्ती को (आम-गर्भ को) इसी घृत में भुजकर खायें, इसी प्रकार (इसी घृत के साथ) जलजल प्राणिजों के मांस को खायें^४। टीकाकार इन्द्र ने पयस्यादि चारों औषधियों से चतुर्गुण घृत तथा उतना ही क्षीर लेने का विधान बताया है तथा आमार्ग से आक्त्रिकालजात अर्थात् सखोजात प्राणी का निर्देश किया है^५।
- i) She should take milk treated with decoction or juice of *madhuka* and *vidār*.
- ii) For increasing the size of *upaviṣṭaka* and growth and development of *upaviṣṭaka* the woman should be advised to take three fat hens (meat of hens) and one *ādḥaka* of husk less *māḍa*, pestle both these with milk and water in a mortar, express the juice, with this juice and *ghrita* cook the meat of partridge, sparrow or any similar bird and take it.
- iii) Rice gruel cooked with *ghrita* extracted from goat's milk, goat's milk and the drugs of *jīvanīya* group should be prescribed.
- iv) The *ghrita* should be prepared by cooking it with milk and paste of *pāyasya*, both *kākolis* and *sunīṣaṇṇaka*. This *ghrita* should be taken with milk in the morning and evening or with soup of egg or embryo or else egg, embryo or meat of aquatic animals should be fried in this *ghrita* and taken. Indu explains that while preparing
१. अथ विद्योषेण वाते पूर्वमेव सैख्योपहितं क्षीरान्तिं दत्त्वा शीतोदकसातं मृदुशाल्योदने भोजयेत्। ततो विद्यादिगणसाधितेन सर्पिषाऽनुवासयेत्। निवातं च सेवेत ॥ (अ० सं० शा० ४/१९)
२. पित्तमुक्तवितरीनैर्वृहसिद्धं पयः पिबेत्। तिस्रः स्थूलकुण्डलिनिसुषमाण्डकं च क्षीरेदकेनोदूखले संशुद्धं तदसेन सर्पिषा च तिनिकिपिञ्जलाच्यतरासं साधयेत्तत्वा पायशुष्यविष्टकविवर्धनाधुमुपयुक्तवृंहणार्थं च। अजासर्पिषा क्षीरेण जीवनीयैश्च संस्कृता यवागू पिबेत्। पयस्याकाकोलीद्वयसुनिषण्णककल्केन पयसा च सर्पिर्विपचेत्। तत्कालं क्षीरगुणमधुघृज्जित। आमार्गभसेन काऽश्रीयात्। तानेव च तत्र भृष्टाः भक्षशेज्जलचरमांसानि च ॥ (अ० सं० शा० ४/२०)
३. पयस्यादीनां चतुर्णां कल्केन तच्चतुर्गुणं सर्पिः पयसा स्नेहसमेन विपचेत्, पयस्या क्षीरविटरी, कालवं प्रातःआमार्गार्थं त्वचिरकालजातानां प्राणिनां। (अ० सं० शा० ४/२० की इन्द्र टीका)

the *ghrita* its amount should be four times to the collective weight of all the drugs and equal to milk, besides egg etc. the meat of newly born animals can also be used.

(इ) कफाधिक्य में चिकित्सा (Treatment in dominance of kapha)

(१) कफाधिक्य (युक्त उपविष्टक एवं उपशुष्क) में तीन, पाँच या सात रात्रि (दिन) तक आनुष तथा ओदक (जलचर) प्राणियों के मांस को उदरस (भोजन के साथ पूछ, प्यास या स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाए गए पदार्थ) के साथ खाकर अच्छासुरा (मदिरा के ऊपर का भाग) का पान करें।^१

(२) तिल, मुद्गा, माष, लवण तथा विल्वपत्र^२ (के चूर्ण) को पंचपात्र मात्रा में (एक पात्र-६४ पल या २५६ तोला^३ अर्थात् कुल १२८० तोला) घृत के एक पात्र (१२८ पल^४) के साथ मिलाकर गुप्त या सुरक्षित स्थान में रख दें। तत्पश्चात् प्रातःकाल उस पिण्ड को (उपयुक्त औषधि एवं घृत मिले हुए पदार्थ को) विल्व-मात्र (विल्वफल के बराबर अर्थात् २ तोला) लेकर गरम करके ठण्डे किए हुए छाग-दुध के अनुपात से प्रयोग करें।^५ उपर्युक्त औषधियों में ही एक पात्र (६४ पल) बदरी चूर्ण भी मिलाकर प्रयोग करें।^६

i) In this condition for three, five or seven consecutive days the meat of aquatic animals or others frequenting marshy or watery places, mixed with condiments to make it dainty and appetizing should be given followed by use of supernatant wine (very fine wine).

ii) Powdered *tila mudga masha*, salt and leaves of *bilva* in the quantity of *pañcapātra* (approx. 12. 80 Kg) mixed with one *pātra* (approx. 5. 12 Kg) of *ghrita* should be kept in secret or protected place. In the morning this preparation should be taken in the dose of *bilva-mātra* (approx. 20 gms) with boiled and then cooled goat's milk. Alongwith above drugs powdered fruit of *jupube* in the dose of one *pātra* (approx. 2. 56 Kg) can also be mixed.

उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ की वृद्धि न होने पर पातन चिकित्सा (Abortifacient treatment of upaviṣṭaka and upaśuṣka garbhā)

एवमवृद्धौ तीक्ष्णैर्विचयेदपातनीयैश्च पातयेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/२२)

इस प्रकार (उपर्युक्त सभी प्रकार की चिकित्सा करने पर भी) न बढ़ते हुये उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ का तीक्ष्ण, विरेचनीय एवं अपातनीय द्रव्यों के प्रयोग द्वारा पातन करा दें।

If the fetus in both these conditions does not develop with above treatment, then its abortion should be induced by the use of pungent and purgative drugs or with the drugs prescribed for expulsion of placenta.

१. कफे त्वाग्नापेदकपिशितोदरशामच्छसुं विप्रां पश्छात्रं समानं वा पिबेत् । तिलमुद्गमाषलवणविल्वपत्रैः पञ्चभिर्नृपात्रां संयोज्य स्वयुक्तं निषाषयेत् । ततः प्रातः पिण्डं विल्वमात्रं भृशशीतच्छागदुधानुपातनं प्रारभेत् ॥ अत्रैव वा बदरीचूर्णपात्रमपि निदध्यात् ॥ (अ० सं० शा० ४/२१)

२. पाठ भेद में 'विल्वपत्रैः' शब्द का प्रयोग हुआ है। विल्व के साथ अंग विशेष का निर्देश न होने पर फल का ही प्रयोग होता है। पाठभेद में पात्र शब्द का प्रयोग औषधि-मात्रा का होता है जो यहाँ युक्ति सेनात नहीं है। (अ० सं० शा० ४/२१ की इन्दु टीका पुस्तक का पाठ)

३. पात्रं शुक्लद्रव्यस्य चक्षुष्मिण्यलानि, घृतस्याद्यांश्चान्यधिकं पलशतम् ॥ (अ० सं० शा० ४/२१ की इन्दु टीका)

विमर्श (Comments)

सामान्य चिकित्सान्तर्गत वर्णित यान-वाहनादि प्रयोग^१ भी गर्भ का पातन ही करायें। प्रारम्भ में गर्भ वृद्धिकारक चिकित्सा करने पर भी यदि उपशुष्क या उपविष्टक गर्भ की वृद्धि न हो तो यान-वाहनादि का प्रयोग कर उसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

Agitating activities, frequent riding etc. may also initiate abortion. After initially treating both these conditions with the measures or drugs for proper growth of the fetus, if it does not grow, riding etc. should be advised for its expulsion.

(४) लीन गर्भ (Lina garbha)

निदान एवं लक्षण (Etiology and clinical features)

यस्याः पुमर्भः प्रसुप्तो न स्पन्दते ॥ (च० सं० शा० ८/२८)

वातोपद्रवगृहीतत्वात् स्रोतसां लीयते गर्भः, सोऽतिकालमवतिष्ठमानो व्यापद्यते ॥

(सु० सं० शा० १०/५७)
यस्याः पुनर्वतीपसृष्टवतीस संलीनो गर्भः प्रसुप्तो न स्पन्दते तं लीनमिच्छाहुः ॥
(अ० सं० शा० ४/२३)

लीनाच्छे निःसृजे ... ॥ (अ० ह० शा० २/१८)

यद्यपि महर्षि चक्र ने वर्णन में कहाँ भी लीन शब्द का प्रयोग नहीं किया परन्तु लक्षणों एवं चिकित्सा में सामंजस्य होने के कारण यह वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

जिस स्त्री का गर्भ सुप्त हो जाने के कारण (अत्यधिक शिथिल या क्रिया-रहित होने के कारण) स्पन्दन नहीं करता (उसे लीन गर्भ कहते हैं)।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि स्रोतों के वात के उपद्रवों से पीड़ित होने के कारण गर्भ लीन हो जाता है। वह अधिक काल तक रहता हुआ (गर्भाशय में रहता हुआ) व्यापद्यित होता है अर्थात् कष्ट को प्राप्त करता है या मर जाता है। टीकाकार डल्हण ने गर्भ की चिरकाल-स्थिति वर्णन करते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि गर्भ के निर्गम मार्ग के स्रोतस् वात के उपद्रवों से गृहीत होकर संकुचित हो जाते हैं एवं अतिकाल-स्थिति के कारण गर्भ का विनाश हो जाता है, वह गर्भ लीन अर्थात् रिलज हो जाता है या स्रोतों में चिपक जाता है^२।

अष्टांगसंग्रहकार ने लिखा है कि पुनः वायु से स्रोतों के उपसृष्ट होने या आक्रांत होने से उनमें (स्रोतों में) गर्भ संलीन (भली भाँति लीन) हो जाने के कारण प्रसुप्त हो जाता है अर्थात् सो जाता है या क्रिया-विहीन हो जाता है एवं स्पन्दन नहीं करता उसे लीन कहते हैं।

अष्टांगहृदयकार ने बहुत ही संक्षेप में लिखा है कि लीन गर्भ में गर्भ निःसृज या निःस्पन्दन होता है।

Though Charaka has not given any name to this entity, yet, due to similarity in clinical features and treatment it has been included here. He says that her fetus being sleepy or idle does not quiver.

१. च० सं० शा० ८/२७; अ० सं० शा० ४/१८ एवं अ० ह० शा० २/१८ (पृष्ठ ३६७, ३६८)

२. अर्थात् चिकित्सालस्थितिर्गर्भविकृतिर्दस्यक्राह-वातेत्यादि । लीयते रिलज्यादि, कुल इत्याह-स्रोतसां गर्भनिर्गममार्गां वातोपद्रवेण सङ्कोचादिना गृहीतत्वात् । व्यापद्यते विनश्यतीत्यर्थः ॥ (सु० सं० शा० १०/५७ की डल्हण टीका)

Suśruta opines that due to abnormalities of *strotasas* caused by complications of *vāyū*, the fetus becomes *līna* (clung or adhered), this fetus remains in uterus for a very long duration and gets various complications. Dāhiana explains that *strotasas* of exit passage of fetus are constricted due to aggravated *vāyū* resulting into prolong intrauterine stay of the fetus and later-on its death. This dead fetus gets adhered to *strotasas*.

Vāgbhata I corroborating etiology given by Suśruta writes further that the fetus becomes idle or inactive and does not quiver. Only absence of quivering has been mentioned by Vāgbhata II.

लीन गर्भ का प्रसवकाल (The period of delivery of līna garbha)

पुष्टोऽप्यथा वर्षगणैः कुच्छाज्जायेत, नैव ॥ (अ० ह० शा० २/२१)

(या तो) पुष्ट होकर (सामान्य समय पर) अथवा वर्षों के उपरान्त अत्यधिक कष्ट से उत्पन्न होता है या नहीं भी उत्पन्न होता, अर्थात् या तो योनिमार्ग से अति कष्ट के साथ प्रसवित होता है अथवा गर्भिणी के जीवन पर्यन्त कुक्षि में ही रहता है^१।

If properly developed, it delivers in time, or else it comes out with great difficulty through vaginal passage after years, however, sometimes it remains in the uterus for entire woman's life.

लीन गर्भ चिकित्सा (Treatment of līna garbha)

अभ्यन्तर प्रयोगार्थ द्रव्य या पथ्य (Oral medication or beneficial diet)

(१) उसका मुटु (अतीक्ष्ण) स्नेहद्वि क्रम से उपचार करें^२ अर्थात् मुटु स्वेदन, वमन, विरेचन आदि में भी स्नेह द्रव्यों का प्राधान्य रखें, क्योंकि तीक्ष्ण वमन-विरेचनादि गर्भोपशान्त करते हैं; कुछ लोग मुटु शब्द से अरुचिजन वर्जित अवचारणा स्नेह के प्रयोग का विधान बताते हैं^३।

(२) रयेन (बाज), मत्स्य, गवय (नील गाय), शिंखि (मयूर), ताम्रचूड़ (मुर्ग), तिलित या अन्य (पक्षियों) का मांस रस, एवं घृत अथवा माष-यूष अथवा अधिक मात्रा में घृत एवं मूली के यूष के साथ रक्तशाली के मुटु (भली भाँति पके हुए), मधुर (शकर आदि मिले हुए) तथा शीतल भात का भोजन दें^४।

अथवा रयेन (बाज), उल्कोश (समुद्री गूढ या कुरारी), गौ, मत्स्य, मयूर, गोषा, मुर्गा, तिलित या अन्य (पक्षी) के मांसरस या अत्यधिक घृत या माषयूष या मूलिकायूष के साथ घृत से मिश्रित रक्त शाली का भात खाने को दें^५।

अथवा केवल उल्कोश (कुरारीभेद) के मांस-रस से साधित अनल्प (अधिक) स्नेह युक्त यवागू पीने को दें^६। अथवा रयेन, गौ, मत्स्य, उल्कोश तथा बहि (मयूर) के मांसरस अथवा माष या मूलक के रस को अधिक मात्रा में घृत मिलाकर दें^७।

(३) मेघ (मेदुर याती मोटे चर्बी वाले जानवरों) का मांसरस अकेला^८ या उपदंश^९ (भोजन में खींच के लिए साथ में घृत मिलाकर दें^{१०}।

१. कुच्छाज्जायेत-कठेन योनिनो निष्क्रामेत्। नैव वेति। अथवा यावज्जीवं गर्भिण्याः कुक्षौवावसीदेत् न ततो निष्क्रामेत् कुक्षौवाविधेत् ॥ (अ० ह० शा० २/२१ की अन्त्या टीका)

नोट- लीन गर्भ चिकित्सा के सन्दर्भ पुष्ट ३७३-३७४ में देखें।

में मिलाई गई वस्तु, मसाला आदि) के साथ तथा मधु^१ या मूत्रीका से बनी^२ (शराब आदि) वस्तुओं का सेवन करना चाहिए^{३,४}।

(४) माष, तिल, बिन्द-शलाटु से साधित कुल्पाष (जबला हुआ चना) खाने को दें, तत्पश्चात् माषकीक-मधु (मधुए की शराब) सात राति तक पीने को दें^५।

अथवा तिल, माष एवं बिन्द-शलाटु से युक्त समू द्राघ के साथ पीने को दें^{६,७}।

(५) उपविष्टक एवं उपशुष्ककर्तात् वर्णित चिकित्सा भी करें^८।

(६) स्त्री को बार-बार प्रसन्न करें^{९,१०}।

i) She should be treated with mild and predominantly unctuous sudation, emesis and purgatives, because strong emetics etc. are likely to harm the fetus. Others opine that use of only *ghṛta* should be avoided, instead, it should be given with some vehicle as mixed with oleo etc.

ii) Soft nicely cooked, sweetened and cooled or simply cooked red *śālī* rice mixed with either meat-soup of (any one available amongst) hawk, fish, *gavaya* (a species of ox), peacock, cock, partridge, sea-eagle or osprey, cow, iguana or any bird with *ghṛta* or only plenty of *ghṛta* or else with soup of *māṣa* or soup of radish along with *ghṛta* should be prescribed in diet.

Rice gruel prepared with meat soup of sea-eagle or osprey mixed with good quantity of fat can also be given.

Either meat-soup of hawk, cow, fish, sea-eagle or osprey and pea-cock or soup of *māṣa* or juice of radish mixed with good quantity of *ghṛta* should be given.

iii) Meat soup of fatty animals with or without condiments or other things likely to make it appetizing and dainty, honey and wine made of *drākṣā* should be given.

iv) Boiled gram cooked with *māṣa*, *tila*, unripe fruit of *bliva* should be given for eating followed by use of wine made from *madhviṅka* for seven days.

Flour of parched barley mixed with *tila*, *māṣa* and unripe fruit of *bliva* can also be given with milk.

v) Treatment prescribed for *upavṛṣṭaka* and *upavṛṣṭaka garbha* can also be used.

vi) The woman should repeatedly be made happy.

१.'तं रयेनमत्स्यावयशिखिताम्रचूडतिरितीणामयतमस्य सर्पिष्मत् रसेन माषयूषेण वा प्रभूतसर्पिषा मूलकयूषेण वा रक्तशालीमोदनेन मुटुमधुरशीतलं भोजयेत्। तैलाप्यङ्गेन चास्या अभीक्ष्णमुदरवतिरिक्षणोत्कटीपाश्चपुष्टदंशाभिघृद्यो-नोपचरेत् ॥ (च० सं० शा० ८/२८)

२.'तं मुदुना स्नेहादिक्रमेणोपचरेत्, उल्कोशरससंस्निग्धमनल्पस्नेहं यवागं पाययेत्, माषतिलबिन्दुशलाटुमिश्रान् वा कुल्पाषान् भक्षयेन्माषमाषकीकं चागुपिबहेत् समस्तम्। कालातीतव्याधिनि गर्भं विशेषतः सषाण्मासपूरुषालं मुसलेनाभिद्वयाद् विषमे वा यानसने सेवेत्। (सु० सं० शा० १०/५७)

(क्रमशः पुष्ट ३७४ में देखें.....)

लीन गर्भ यातन (Treatment for expulsion of lina garbha)

उपयुक्त अधिकांश चिकित्सा स्रोतोंवरीलवकाक वायु के शमन की विधि है। वात का शमन हो जाने पर स्त्रियों के चिकित्सा के लिए निम्न चिकित्सा करें:-

ईषत् उष्ण तैल के द्वारा उदर, बलित^१ वक्षः, उरु, कटि, पार्श्व एवं पुष्ट प्रदेश^{१,२} में अथवा केवल कटि प्रदेश में बार-बार अभ्यास करें। विशेषकर कालातीतस्यायी (प्रसव का समय निकल जाने पर भी स्थित) गर्भ में धान्य-युक्त उद्बल्लत को मूसल से कूटे या विषम यान एवं आसन का सेवन करें।^३

Most of the preparations enlisted above suppress the vāta responsible for constipation of *strotasas*. Once vāta is suppressed, following procedures should be adopted for producing dilatation of *strotasas*.

Repeated massage over abdomen, urinary bladder-region, groins, thighs, sacral region, flanks and back should be done with luke-warm oil. Specially in case of prolonged intra-uterine stay of fetus the woman should pestle paddy in a mortar, use vehicle moving on uneven path or sit over uneven place.

(५) गर्भक्षय (Garbhakṣaya)

लक्षण (Clinical features)

गर्भक्षये गर्भासन्तनमुन्नतकुक्षिता च ॥ (सु० सं० सू० १५/१२)

गर्भक्षय में गर्भ का स्तनन न होना तथा कुक्षि का अनुन्नत (नीचा या पिचक जाना) होना आदि लक्षण होते हैं। आचार्य भवमिश्र ने उपयुक्त वर्णन के ही साथ लिखा है कि गर्भक्षय पीडित स्त्री मृग, अना, आदि तथा वराह के सुसंस्कृत गर्भों के मांस, वसा या भुने हुए मांस के अनेक प्रकार (कवाव) आदि खाने की इच्छा करती है।^४

In *garbhakṣaya* absence of quickening and decrease in height of uterus are the clinical features.

Bhāvamiśra corroborating above view says further that in this condition woman de-

(पृष्ठ ३७३ से आगे.....)

३. तत्र स्थेनोत्कण्ठोत्पत्त्येवमिति विदुः कुरुतीति शोणमन्त्रमस्य स्तेन भूतिसिक्केण माषवृषेण मूलकवृषेण वा घृताब्जेन रक्तशालयोदनं भोजयेत्। सक्तुन्वा तिलमण्डिलवशलादुत्तुकात् पयसा पाययेत्। मेघमांसोपदेशं वा माद्विकम्। तैलेन चाभीक्ष्णमुदरवक्षोः लन्टीपार्वर्षमभ्यञ्जयेत् ॥ मुहुर्भुङ्क्ष्वन्तं इधयेत्। पूर्वोक्तं चेक्षेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/२४)

४.स्थेनोत्पत्त्योत्कण्ठोत्पत्त्येवमिति विदुः कुरुतीति शोणमन्त्रमस्य स्तेन भूतिसिक्केण माषवृषेण मूलकवृषेण वा घृताब्जेन रक्तशालयोदनं भोजयेत्। सक्तुन्वा तिलमण्डिलवशलादुत्तुकात् पयसा पाययेत्। मेघमांसोपदेशं वा माद्विकम्। तैलेन चाभीक्ष्णमुदरवक्षोः लन्टीपार्वर्षमभ्यञ्जयेत् ॥ मुहुर्भुङ्क्ष्वन्तं इधयेत्। पूर्वोक्तं चेक्षेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/२४)

रसा बहुधृता देया माषमूलकजा अपि। बालवित्तं तिलाग्नायास्तुंश्च पयसा पिबेत् ॥ १९॥

समेष्टमांसं मधुं वा कट्याभ्यङ्गं च शालयेत्। इधयेत्सततं चैनमेवं गर्भः प्रवर्धते ॥ २०॥

पुष्टोऽन्यथा ॥ (अ० सं० शा० २)

५. मृदुना अतीक्ष्णेन, तीक्ष्णस्य गर्भोपघातकत्वात्। स्तेहादितैलनादिशब्दो न व्यवस्थावाची, तीक्ष्णस्वेदस्य वमनविरचनयोश्च गर्भोपघातकत्वात्, अत आदि शब्दः प्रथमान्वयी, तेन स्तेहप्रधानानुक्रमेणोत्तरार्धः। अन्ये पुनर्मृदुनाति अच्छणवतावधारणा-स्तेहेनेति मन्यन्ते। एवं सौतोसामवरोपहेतोर्वातस्योपशमविधिमुक्त्वा वातोपशममुद्भूतानां स्रोतसां विकाराद्यं विधिं दर्शयन्नाह-कालातीति इत्यादि।। (सु० सं० शा० १०/५७ की इच्छा टीका)

६. अनुन्नतो भवेत्कुक्षिर्गर्भस्यासन्तं तथा। इति गर्भक्षये प्राज्ञैर्लक्षणं समुदाहृतम् ॥ १३॥
मृगजानिवराहाणां गर्भान्वाच्छति संस्कृतान्। वसाश्चूल्प्रकादीन्भोक्तुं गर्भपीक्षये ॥ १३॥ (पा० प्र० पूर्व० ७)

sires to eat well prepared meat of fetuses of deer, goat, sheep and hog alongwith fat and other roasted meat preparations.

चिकित्सा (Treatment)

(१) बलित-काल प्राप्त होने पर अर्थात् आठवाँ महीना हो जाने पर क्षीर-वस्ति तथा मेघ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। टीकाकार इच्छा ने मेघ अन्न शब्द से निम्न अन्न के प्रयोग तथा 'मेघाण्डोपयोग' आदि पाठभेद का वर्णन करते हुए मेघ से वृष यथा वस्त, मत्स्य आदि के अण्ड (वस्त का वृषण एवं मत्स्य का अण्ड) के प्रयोग का विधान लिखा है।^१

(२) दोष, धातु, मल या वल क्षीण मनुष्य उन उन क्षीण हुए पदार्थों के वृद्धिकारक द्रव्यों के ही खाने की इच्छा करता है, अतः क्षीणता (किसी दोष, धातु या मल की) से पीडित व्यक्ति जो जो खाने की इच्छा करे वह देना लाभप्रद है अर्थात् उपयुक्त मृगादि का मांस सेवन गर्भ-वृद्धि-कारक है।^२

i) Once the woman has reached her eighth month of pregnancy she should be given enema of milk followed by use of unctuous cereals. Dahana explains that cereals mixed with fat or meat of testicles of goat and eggs of fish should be given.

ii) In all the conditions of *ksaya* (decline or loss) of *dosa, dhātu, mala* or *bala*, the individual desires to take the substances likely to increase the same, thus the person suffering from loss of any one of above should be given desired things, since those are beneficial because they compensate the loss.

(६) गर्भवृद्धि (Garbhavṛddhi)

लक्षण (Clinical features)

गर्भो जठराग्निवृद्धिं स्वेदं च ॥ (सु० सं० सू० १५/१६)

गर्भवृद्धि (अति वृद्धि) में उदर की अति वृद्धि तथा स्वेद (अधिक) लक्षण होते हैं।

आचार्य भवमिश्र ने उदरादि की अति वृद्धि, गर्भिणी को स्वेद तथा प्रसव में महान कष्ट आदि लक्षणों का वर्णन किया है।^३

In *garbhavṛddhi* there is excessive increase in size of abdomen and perspiration Bhāvamiśra adds further that labour is much difficult.

चिकित्सा (Treatment)

सामान्य रूप में वृद्धि में यथायोग्य, सात्व्य, संशोषन तथा संशमन आहार-विहार द्वारा चिकित्सा, जो क्षय के अतिरिक्त

१. तत्र प्राणवस्तिस्कालायाः क्षीरवस्तिप्रयोगो मेघान्नोपयोगश्चेति ॥ १२॥

(प्राणवस्तिस्कालाया इति प्राणाष्टमसाया इत्यर्थः। मेघान्नोपयोग इति निम्नधात्रोपयोगः। मेघाण्डोपयोग इत्यन्ये पठन्ति। मेघाण्डानि वृषाण्डानि, वस्तमत्स्याण्डानििति व्याख्यानयन्ति-इच्छं०) (सु० सं० सू० १५/१२ एवं इच्छा टीका)

२. दोषधातुमलक्षीणो बलक्षोणोऽपि मानवः। तत्तत्सर्वद्वर्तनं यत्तद्वर्णनं प्रकाङ्क्षति ॥ १५॥

यद्यद्विहाजानतु क्षीणः प्रार्थयेत् नः। तस्य तस्य स लाभेन तत्तत्क्षयमवाहति ॥ १६॥ (पा० प्र० पूर्व० ७)

३. उदरादिप्रवृद्धिस्तु वृद्धे गर्भोऽभिजायते। स्वेदश्च गर्भवत्याः स्यात्प्रसवे व्यसनं महत् ॥ ७३॥ (पा० प्र० पूर्व० ७)

अर्थात् उस उस वृद्ध दोष या धातु का क्षय न करते हुए केवल बढ़ी हुई मात्रा के ह्रासकारक आहार, विहार एवं चिकित्सा का प्रयोग करें।^१

Generally beneficial, congenial purifying and suppressive dietetics and mode of life, not causing loss of that *dosya* or *dhām* but capable of decreasing the increased substances should be used.

(७) वातोदर (Vātoḍara)

कदाचिद्धा गर्भ इव वातोदरं भवति तद्वातोपशमनैरपशाम्यति ॥ (अ सं० शा० १/१५)

कभी कभी गर्भ के ही समान (उदर को बढ़ाने वाला) वातोदर हो जाता है जो वातशामक चिकित्सा करने पर शान्त हो जाता है।

Some times abdomen is increased just like pregnancy due to vāta, which subsides with the treatment capable of suppressing the vāta.

(८) भूतहत या नैगमेषहत गर्भ (Bhūta or nāigamesahatya garbha)

महर्षि चरक एवं वागपट ने भूतहत गर्भ का पृथक् उल्लेख किया है। महर्षि सुश्रुत तथा उनके अनुयायी आचार्य भवामिश्र एवं योगरत्नाकर ने नागोदर के ही साथ नैगमेय या नैगमेषहत गर्भ का वर्णन किया है। महर्षि काश्यप ने रक्तुल्म में भेदन के बाद गर्भ के अदृश्यमान होने की स्थिति को 'दिव्य गर्भ' या परिप्लुत गर्भ' माना है। वर्णन निम्नलिखित है।

असुश्निरुद्धं पवनेन नार्यां गर्भं व्यवस्यन्त्यबुधः कदाचित्।
गर्भस्य रूपं हि करोति तस्यास्तदायुः (सम)स्त्रावि विवर्धमानम् ॥

तदनिर्णयंश्रमशोकोरोगैरभ्याघातपारैरथवा प्रवृत्तम्।

दृष्ट्वासुशोकं न च गर्भसंज्ञं केचिन्नरा भूतहतं वदन्ति ॥ (च० सं० शा० २/८, ९)

शुक्रशोणितं वायुनाऽभिप्रपन्नमवकान्तजीवमाध्यापयत्युदरम्। तत् कदाचिद् यदृच्छयोपशान्तं नैगमेषापहतमिति भाषन्ते ॥ (सु० सं० शा० १०/५७)

तदेव कदाचिदार्तवं सौम्यैर्दृष्ट्वात्मभिराहारविहारैः स्तम्भितमनुपद्रवमेवोदरं गर्भाधिष्ठितमिव वर्धयति। येन तामगर्भा गभिर्गोमिमाहुर्मूढाः ॥ १६॥

ततो विपरीतैर्यदृच्छया वा प्रवृत्ते रक्ते गर्भशरीरमपश्यन्तो भूतहतमितिज्ञां ब्रुवते ॥ १७॥

(अ० सं० शा० १/१६ व १७)

अवस्थितं लोहितमङ्गनाया, वातेन गर्भं ब्रुवतेऽग्निभिज्ञाः।

गर्भाकृतित्वात्कटुकुष्णातीक्ष्णैः, स्तुते पुनः केवल एव रक्ते ॥ ६१॥

गर्भं जडा भूतहतं वदन्ति, मूर्तेन दृष्टं हरणं यत्सर्वैः ॥ (अ० ह० शा० २/६१, ६२)

१. (अ) तेषां यथारसं संशोधनं क्षापणं च क्षयादतिरुद्धैः क्रियाविशेषैः प्रतिब्रुवति ॥ १७॥

(यथास्त्वं यद्यदप्यारतपीयम्। क्षपणमत्र संशमनम्। क्षयादतिरुद्धैः क्रिया विशेषैरिति तन्मन्त्रोक्तैः।

“तेषां क्षपणविलरुद्धैः क्रियाविशेषैः कुर्वति।” क्रियाविशेषैरिति क्रियाः संशोधनसंशमनाहारायाज्याः—(इल्ल०)

(सु० सं० सू० १/५१७ एवं इल्ल० टी०)

(अ) तत्तदभ्यासकाराहारविहारपरिषेवणत्। दोषधातुपञ्चानां हि ह्रासो निगदितो नृणाम् ॥ ७४॥ (पा० प्र० पूर्व० ७)

केचिन्त्यथ कालेन निर्भेदं यदि गच्छति ॥ ३६॥

ततो गुल्मप्रमुक्ता सा ज्ञातिमध्ये प्रभाषते। गर्भिण्यहं विरं भूत्वा प्रस्युते गर्भशोणिते ॥ ३७॥

गर्भरूपं न पर्याप्ति तत्र मे संशयो महान्। तामिदं प्रतिभाषन्ते सर्वार्थामकुल्लताम् ॥ ३८॥

दिव्यो गर्भो व्यतिक्रान्तो नैगमेषेण ते हतः। इत्येतानामबुधाः प्राहुर्हतं सर्वमशोषनम् ॥ ३९॥

परिप्लुत इति प्राहुः कुशला ये मनीषिणः ॥ ४०॥ (का० सं० छिल्ल० १)

वायु के द्वारा रक्ते हुए या बँधे हुए आर्तव को देखकर कभी कभी अज्ञानी लोग उसे गर्भ (हो गया है इस प्रकार का) निश्चय कर लेते हैं। वह न निकला हुआ अर्थात् रक्ता हुआ आर्तव गर्भाशयान्तर्गत बद्धकर गर्भ के लक्षणों (आर्तव, स्तन परिवर्तन कुक्षिवर्धन आदि) को कर देता है। वह (रक्ता हुआ आर्तव) अग्नि (अग्निताप), सूर्य (सूर्यताप), श्रम, शोक, तेग (अथवा रोष या क्रोध) अथवा उष्ण अन्नपान के प्रयोग से प्रवृत्त हो जाता है (अर्थात् योगिमार्ग से बाहर आने लगता है)। केवल रक्त को ही देखकर एवं गर्भ को न देखकर कुछ लोग उसे भूतहत कहने लगते हैं (अर्थात् रक्तस्राव के समय गर्भ की अनुपस्थिति के कारण भूतों ने गर्भ का हरण कर लिया ऐसा मानने लगते हैं)।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि वायु से पीड़ित शुक्र-शोणित जीवात्मा को अवक्रान्ति होने के बाद उदर का आत्मान कर देते हैं, वह कदाचित् स्वयमेव शांत हो जाने पर नैगमेषापहत कहलाता है।

अष्टांगसंहारक ने लिखा है कि वही आर्तव कभी-कभी सौम्य, वृंहण एवं आत्मानकृत आहार-विहार के प्रयोग के कारण स्तम्भित होकर उदर (गर्भाशय) को गर्भाधान की तरह ही बढ़ाता है। इस प्रकार की (आर्तवविरोध तथा उदर-वृद्धि प्राप्त) अगर्भा (गर्भ रहित) स्त्री को अज्ञानी लोग गर्भिणी कहते हैं। वही (रक्ता हुआ आर्तव) विपरीत (सौम्य एवं वृंहण के विपरीत) द्रव्यों के प्रयोग या इच्छा अर्थात् बिना किसी कारण के ही प्रवृत्त होता है तो गर्भ के शरीर को न देखने के कारण भूत ने हरण कर लिया ऐसा कहते हैं। टीकाकार इन्दु ने सौम्यादि के विपरीत औषधियों के प्रयोग से काकाली न्याय के द्वारा अथवा विज्ञ-चिकित्सक के द्वारा औषधि प्रयोग को आर्तव प्रवृत्ति का कारण माना है^२।

अष्टांगहृदयकार ने लिखा है कि स्त्री में रक्त के वायु के द्वारा रुक जाने को अनभिज्ञ लोग गर्भाकृति (गर्भ-सदृश गर्भाशय में स्थिति, उन्नाति अर्थात् उदरवृद्धि, ह्रस्वता, दौहद तथा सत्य-दर्शन, आदि रक्तगुणान्नाति वर्णित लक्षण) होने के कारण गर्भ कहने लगते हैं, अर्थात् स्त्री गर्भिणी है ऐसा कहने लगते हैं। फिर कटु, उष्ण एवं तीक्ष्ण द्रव्यों के प्रयोग से रक्तस्राव होने पर केवल रक्त को ही देखकर गर्भ को भूत ने हरण कर लिया, इस प्रकार जड़ या मूर्ख लोग कहते हैं, यद्यपि उन्होंने कभी भी भूतों के द्वारा मूर्त (दृष्टिगोचर योग्य गर्भशरीर या अन्य शरीर) को हरण होते देखा नहीं है।

महर्षि काश्यप ने रक्तुल्म के भेदन के बाद की अवस्था को ही भूतहत गर्भ मानते हुए लिखा है कि किसी भी कारण या काल के द्वारा यदि (रक्तुल्म) भेदन को प्राप्त होता है, तब वह गुल्म से मुक्त होने पर अपने परिवार वालों से कहती है कि चिरकाल तक गर्भिणी होने पर भी गर्भ का रक्त निकल जाने पर गर्भ के रूप को न देखकर मुझे अत्यधिक

१. “असुश्निरुद्धं” का “असु” विवर्द्ध “पाठभेद” है।

२. “.....। गर्भाशये हि विवर्धमानम् रोधिरं प्रभावादर्भात्तन्नि कानिचिद्वर्धयतीत्यर्थः ॥

३. “शोकोरोगैः” का “शोकोरोगैः” पाठभेद अधिक युक्तिसंगत है, क्योंकि शोक एवं क्रोध दोनों ही मानसिक आघात उत्पन्न करते हैं। (च० सं० शा० २/८ की चक्र० टीका)

४. ततोऽनन्तरं सौम्यादिहेतुविपरीतैः काकालीयेन साधु पिषाया वा प्रयुक्तैः स्वयमेवौषधनिपक्षया वा प्रवृत्ते रक्ते। (अ० सं० शा० १/१७ की इन्दु टीका)

५. गर्भाकृतित्वादिति। गर्भमाकृतिः संस्थानमुन्नत्यादिकम् तथा ह्रस्वसदौहृद इत्यादि रक्तगुणनिर्णयके लक्षणं।

(अ० ह० शा० २/६१ की अरण्य० टीका)

संज्ञा हो रहा है (कि ऐसा क्यों हुआ ?)। गाँव की कौतूहलपूर्ण स्त्रियाँ उसे कहती हैं कि तुम्हारा दिव्य गर्भ जो उत्पन्न हुआ था वह नेमेघ के द्वारा हरण कर लिया गया। इस प्रकार अज्ञानों लोग इसे 'हृत' (हरण कर लिया गया) कहते हैं। जब कि कुशल एवं ज्ञानी लोग इसे परीक्षित कहते हैं।

आचार्य भवामित्र एवं योगरत्नकारक ने महर्षि सुश्रुत मद्रुश ही शुक्रतत्व द्वारा निर्मित अजानाङ्ग गर्भ के जीव विरहित होने के बाद वायु द्वारा आध्माशित हो पुनः शत होने की स्थिति को नेमेघावहृत गर्भ माना है।

Caraka and Vāgbhata have described this condition as a separate entity while Sūśruta etc. have included it under *nāgōdara* as described earlier. Kāśyapa opines that after expulsion (*bhēdāna*) of *raktāgūlma*, when fetal parts are not seen the condition is known as *divya garbha* or *paripiluta garbha*.

Caraka says that observing the obstruction or absence of *ārtava* (menstruation) due to *vāyu*, the unwise persons consider it as pregnancy. This obstructed *ārtava* getting accumulated inside the uterus presents the features of pregnancy, later on starts its flow due to effect of fire, sun (heat of fire or sun), exertion or fatigue, grief, diseases or anger and use of hot articles in the diet. Observing only blood and no fetus, some of the persons say that the fetus has been taken away by *bhūtas*.

Sūśruta says that *śukra* and *śonita* afflicted by *vāyu* after descent of *jīvātmā* produce abdominal distension which sometimes subsides without any cause then it is said that *naigameśa* has taken away the fetus.

Both the Vāgbhata have given almost similar description as given by Caraka, however, Vāgbhata I has described use of *sumnya* (mild), *vṛṇhāna* (anabolic) and favourable (to once own nature) diet and mode of life as the causative factors for cessation of *ārtava* and use of contrary to these or treatment by wise physician responsible for its excretion. Vāgbhata II has enlisted use of bitter, hot and pungent things responsible for excretion of *ārtava*.

Kāśyapa accepting this entity as a latter stage of *raktāgūlma* says that when due to any cause or time factor the *raktāgūlma* gets detached and is expelled, then the woman getting relieved from *raktāgūlma* says to her family members that after carrying the pregnancy for a considerable period and having seen only discharge of blood without expulsion of fetus I am getting very apprehensive. The curious village women say that *divya* (divine) fetus which you were carrying has been taken away by *naigameśa*, thus ignorant persons call it as a taken away fetus and wise persons as *paripiluta garbha*.

Opinion of Bhāvanīśīra and Yogaratnākara is identical to Sūśruta.

चिकित्सा (Treatment)

महर्षि सुश्रुत ने लीनगर्भवत् तथा आचार्य भवामित्र एवं योगरत्नकारक ने धान्य-कुट्टन ही मुख्य चिकित्सा बताई है।

Sūśruta says that treatment prescribed for *līna garbha* should be used in this condition

१. धान्य ५० वि० ७०/१८, १९ एवं १०० तथा यो० १० स्त्री० वि० (पृष्ठ ३६४)
२. सु० सं० शा० १०/५७, धान्य ५० वि० ७०/१०१ तथा यो० १० स्त्री० वि० (पृष्ठ ३६७)

also. Bhāvanīśīra and Yogaratnākara write that pestling of paddy is its principle treatment. गर्भ का भूतों के द्वारा हरण किये जाने की मान्यता का खण्डन (Contradiction of hypothesis about fetus being carried away by bhūtas)

ओजोशनानां रजनीवराणामाहारहेतोर्न शरीरमिष्टम् ।

गर्भ हेरेयुर्दि ते न मातुर्लब्धावकाशा न हेरेयुजः ॥ (च० सं० शा० २/१०)

यसमात्मभवत्योसोऽपहराणं रक्षोभिर्न तु कायस्यानिष्टत्वादशकेर्वा । इच्छाशक्त्योर्हि प्रवृत्तेरुपलब्धिर्न च दृश्यते कस्यचिदमातुर्बुद्धेर्हपहराः ॥ १८ ॥

यदि च दृष्टमपि समुद्रद्वय केचित्तिशयशक्तिकृता गर्भस्य शरीराक्षेपे प्रवर्तते तदा कश्चिन्निव प्राप्तावसा-स्तज्जनीरपेक्षेरन् ॥ (अ० सं० शा० १/१८, १९)

ओजोशनत्वादशत्वाऽव्यवस्थेर्भूतेरपेक्षेत न गर्भमाता ॥ (अ० ह० शा० २/६२)

ओज का भक्षण करने वाले रजनीचर या राक्षसों को शरीर का भक्षण इष्ट नहीं होता, क्योंकि यदि वे (राक्षस) गर्भ (शरीर) का हरण करते हैं तो अवसर मिलने पर (गर्भिणी के शरीर में प्रवेश का अवसर पाकर) माता का ओज न हरण कर लेते (अर्थात् वे राक्षस गर्भ के शरीर को न हरण कर माता का ओज ही हरण करते जिससे माता की मृत्यु हो जाती पर ऐसा नहीं होता अतः भूत गर्भ का हरण नहीं करते) ।

अष्टासंग्रहकार ने लिखा है कि राक्षसों के द्वारा ओज का अपहरण तो सम्भव है, परन्तु अनिष्ट (इच्छाहीनता) तथा अशक्ति (शक्ति-विहीनता) होने के कारण शरीर का हरण सम्भव नहीं है। इच्छा एवं शक्ति की उपलब्धि दिखाई नहीं देती, क्योंकि कभी भी किसी मनुष्य के देह का अपहरण (भूतों द्वारा) देखा नहीं गया। यदि इस दुस्य बात का उल्लेखन करके अतिशय शक्ति-युक्त (कोई राक्षस) गर्भ के शरीर के नाश में प्रवृत्त हो जाय तो वह अवसर मिलने पर माता के शरीर की उपेक्षा क्यों करता है (अर्थात् वह माता का भी अपहरण कर लेगा)। टीकाकार इन्दु ने स्पष्टीकरण में लिखा है कि कभी कभी भूतों की इच्छा होती है पर शक्ति नहीं एवं कभी शक्ति होती है पर इच्छा नहीं, अतः 'इच्छाशक्ति' के अभाव में वे शरीर का अपहरण नहीं कर सकते। अतिशय शक्ति-युक्त राक्षस माता के स्थूल शरीर का भी अपहरण कर सकते हैं आदि भूतों की अनिष्टशक्तिका का वर्णन अनुमानगम्य है एवं आचार्यों ने सम्भजन मान का ही वर्णन किया है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर के लिए कहा जाता है कि हरण करना देखा नहीं गया, उसी प्रकार राक्षसों द्वारा ओज का भी अपहरण देखा नहीं गया यह सब अनुमान के ही आधार पर वर्णन है।

अष्टासंग्रहकार ने संक्षेप में लिखा है कि भूत ओज का भक्षण करने वाले होते हैं। यदि गर्भ का ही भक्षण करते तो माता की उपेक्षा नहीं कर सकते अर्थात् माता के शरीर एवं ओज का भी भक्षण कर लेते।

The *rākṣasas* eat *ojas*, do not desire to devour body, if these carry away the body of fetus, then getting the opportunity to enter inside the body could have eaten away the *ojas* of mother, or in other words once they have entered the body of woman then instead of taking away the body, these would have carried away the maternal *ojas* which is not seen in practice, thus it can be said that *bhūtas* do not carry away the fetus.

१. लब्धावकाशा इति प्रासंगीर्भयभ्रमनकारणाः ॥ (च० सं० शा० २/१० की चक्र० टीका)

२.ननु कथं न सम्भाव्यत इत्याह अनिष्टत्वात्, अथवाशक्तिः शक्तोऽपि कदाचिदनिष्टे न प्रवर्तते दृष्टेऽपि वा अशक्त्या न प्रवर्तते।। अतोऽनुमानात् ज्ञानवे शरीरापहरणं भूतानानिष्टमशकता वा वेति। एतच्चाचार्यस्वसंगमन-प्रवर्तनमिति कृत्वा गृह्यते। अन्यथा शरीरवदेनासि पर्युत्प्लुतः किमुतर् दास्यति ॥

(अ० सं० शा० १/१८, १९ की इन्दु टीका)

Both Vāṇbhāṭas have also given almost similar description. Vāṇbhāṭa I explains further that these *bhūtiās* neither have desire nor the power to carry away the body, because the presence of both these i. e. desire and power is not observed as the carrying away of body by *bhūtiās* is not seen. Even if it is believed that over powerful *ṛksāsas* can indulge in destruction of fetal body, then why should they spare the mother? or they will take the maternal body also. Indu elaborating power and desire says that these *bhūtiās* sometimes possess desire but no power and sometimes power but not desire, thus due to absence of both these together can not carry away the body. The description of taking away the body by over powerful *bhūtiā* etc. is all based on conjectures, similarly taking away of *ojas* has also been given by guess or in other words the theory of carrying away of fetus by *bhūtiā* is not correct.

विमर्श (Comments)

गर्भसाव एवं फल के वर्णन का विमर्श पूर्व वर्णित है (पृष्ठ ३३०-३३१)। इन दोनों वर्णनों के अतिरिक्त विभिन्न आचार्यों द्वारा वर्णित आठ अन्य विकारों का स्पष्टीकरण यद्यपि निश्चित रूप से करना कठिन है क्योंकि आचार्यों में वर्णन-दृष्ट्या कुछ मतभेद प्रतीत होता है, विशेषकर गर्भशोष, उपाविष्टक, उपशुष्क या नागोदर तथा लीन गर्भ के वर्णन में। विषय में आगे बढ़ने के पूर्व उपर्युक्त व्याधियों का विभिन्न आचार्यों के मत से संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है-

तालिका ८

संहिता	निदान	लक्षण	प्रसव-काल	चिकित्सा-सिद्धान्त
		गर्भशोष		
चक्र	रक्तसाव अथवा पोषणाभाव	गर्भ का शोष	वर्ष-गण	जीवनीय, वृंहणीय, स्निग्ध द्रव्य
सुश्रुत	वात-प्रकोप	गर्भ का शोष, कुक्षि का अपूरण, मन्द स्पन्दन (ओज विरहिता-इत्युक्त)	-	मृदु स्नेहादि प्रयोग, मोक्षस प्रयोग, अंत में धान्य-कुट्टन
अष्टांगसंग्रह	प्रकुपित वायु द्वारा रक्तवाही स्रोतों का शोष	वातरोगी, हीनगर्भ	वर्ष-गण	जीवनीय वृंहणीय, स्निग्ध-द्रव्य
अष्टाङ्गहृदय	-	-	-	-
		उपाविष्टक		
चक्र	संज्ञासार गर्भ में उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग, योनि से रक्त या अन्य साव	गर्भ की अवृद्धि, काला-तीव्र स्थिति	अतिकाल के पश्चात्	जीवनीय, वृंहणीय, घृत एवं आम गर्भ का प्रयोग तथा यान-वाह-नादि द्वारा क्षोभन
सुश्रुत	-	-	-	-

संहिता	निदान	लक्षण	प्रसव-काल	चिकित्सा-सिद्धान्त
अ० सं०	संज्ञासार गर्भ में वर्ज्य आहार-विहार सेवन से सतत परतु अल्प रक्तसाव से वात-वैगुण्य तथा अन्य दोषों का अग्रगमन एवं गर्भ की रसवहा नाड़ी का अवरोध	कुक्षि की अवृद्धि, गर्भ के अपरिहियमान होते हुए स्फुरण, अन्य दोषों के लक्षण	वर्ष-गण	चक्र-सदृश; अन्त में गर्भपात कराना
अ० ह०	संज्ञासार एवं वृद्ध गर्भ में रक्तसाव	अ० सं० सदृश	-	च० सदृश
चक्र	आहार वैषम्य या स्नेह की कमी के कारण वात-प्रकोप अग्रगमन	उपशुष्क या नागोदर गर्भ की अवृद्धि एवं कालातीव्र-स्थिति	उपविष्टकवत्	
सुश्रुत	गर्भ की अत्यधिक प्रारम्भ-वस्था में वायु-प्रकोप	गर्भ का प्रतीयमान या छोटा हो जाना अथवा भैगमेष द्वारा हरण कर लिया जाना	-	मृदु-स्नेहादि उपक्रम एवं धान्य-कुट्टन तथा विषम-यानादि सेवन
अ० सं०	उपाविष्टक सदृश, परतु योनि से रक्त तथा अन्य प्रकार के अत्यधिक साव	गर्भ एवं कुक्षि की वृद्धि का ह्रास, किंचित स्फुरण, विभिन्न दौषिक लक्षण	वर्ष-गण	उपाविष्टकवत्
अ० ह०	चक्रसदृश	गर्भ का कृश एवं शुष्क होना, उदर की वृद्धि का ह्रास, चिकित्सा में स्पन्दन	-	उपाविष्टकवत्
चक्र	-	लीन-गर्भ गर्भ की प्रसुता एवं अस्यन्दन	-	
सुश्रुत	प्रकुपित वायु से गर्भ-निर्गम-मार्ग के स्रोतों का अवरोध	गर्भाशय स्थित गर्भ की कष्ट या मृदु एवं स्रोतों में उसका लीन हो जाना	अतिकाल तक स्थिति	अभ्यंग मृदु-स्नेहादि उपक्रम, धान्य-कुट्टन, विषम यानादि सेवन चक्रवत् एवं स्त्री को बारबार प्रसव कराना
अ० ह०	अ० सं० होना	गर्भ की प्रसुता, अस्यन्दन एवं लीना	-	अ० सं० सदृश
	-	गर्भ का अस्यन्दन	वर्षगण अथवा अप्रसव	

उपयुक्त तालिका-८ से स्पष्ट हो जाता है कि गर्भशोथ गर्भ के सामान्य पोषण न मिलने के कारण गर्भ के अति-दोबल्य को एक स्थिति है।

उपविष्टक गर्भ का वर्णन महर्षि सुश्रुत ने नहीं किया, अन्य आचार्यों ने इसे संज्ञातसार एवं वृद्ध गर्भ अर्थात् गर्भावस्था के चतुर्थ मास के उपरान्त की व्याधि माना है तथा मुख्य लक्षणों में योनि से रक्त या अन्य प्रकार के स्राव एवं कुक्षि का न बढ़ना तथा गर्भ में स्पन्दन होना लिखा है।

उपशुष्क या नागोर के वर्णन में आचार्यों में अत्यधिक मतभेद है। महर्षि चारक एवं अष्टांगहृदयकार ने जहाँ इस व्याधि से पीड़ित होने की गर्भ की किसी आयु या अवस्था का वर्णन ही नहीं दिया, वहीं महर्षि सुश्रुत ने इसे स्पष्ट रूप से गर्भावस्था के अति प्रारम्भिक दिनों की व्याधि माना है। अष्टांगसंग्रहकार ने इसे भी संज्ञातसार अर्थात् गर्भावस्था के चतुर्थमासोपरान्त की ही व्याधि माना है। महर्षि सुश्रुत ने नागोर की ही एक स्थिति को नैपमेघ के द्वारा हराण कर लिया हुआ गर्भ कह कर वर्णित किया है। इस वर्णन का कारण महर्षि सुश्रुत द्वारा नागोर व्याधि का गर्भावस्था के प्रारम्भिक दिनों में होना माना जा सकता है, क्योंकि इस काल में गर्भ के शरीर का विकास बहुत ही अल्प होता है, ऐसा सम्भव हो सकता है कि कभी कभी स्त्री को गर्भस्राव होते समय गर्भाङ्ग न दिखाई दें एवं वह उसे नैपमेघावहत मान ले एवं जब गर्भ गर्भाश्यान्तर ही पड़ा रह जाय एवं वृद्धि को न प्राप्त हो तो उसे नागोर माना गया हो। अन्य किसी आचार्य ने इस व्याधि के कारण-स्वरूप योनि से रक्तस्राव का वर्णन नहीं दिया परन्तु अष्टांगसंग्रहकार ने योनि से रक्त या अन्य प्रकार के स्रावों का वर्णन दिया है।

लीन गर्भ को सभी आचार्यों ने गर्भ की प्रसूता अथवा अस्पन्दन की अवस्था माना है। कारण के वर्णन में महर्षि सुश्रुत तथा अष्टांगसंग्रहकार ने स्रोतों का अवरोध लिखा है जिसे टीकाकार डल्हन ने स्पष्टतया गर्भ के निर्गम-मार्ग के स्रोतों का अवरोध माना है।

महर्षि सुश्रुत ने किसी भी प्रकार के गर्भ का वर्षों के बाद प्रसव वर्णित नहीं किया। केवल लीन गर्भ को अतिकाल तक स्थित रहने वाला बताया है। जब कि महर्षि चरक ने गर्भशोष पीडित गर्भ का तथा अष्टांगहृदयकार ने लीन गर्भ का वर्णन-गण में प्रसव माना है, अष्टांगसंग्रहकार ने गर्भशोष, उपविष्टक तथा उपशुष्क सभी का वर्षों के बाद भी प्रसव वर्णित किया है।

किसी भी प्रकार के गर्भ का अपने पूर्ण प्रसवकाल की मर्यादा का एक सीमा से परे उल्लंघन हो वर्षों के बाद शिशु का प्रसव होना सम्भव प्रतीत नहीं होता, आचार्यों द्वारा इस तथ्य के वर्णन के निम्न कारण हो सकते हैं।

(१) किसी अन्य कारण से हुए अनर्तव्य काल में गर्भाधान हो जाने से निश्चित गर्भाधान-तिथि के ज्ञान के अभाव में आचार्यों ने गर्भाधान की सीमा का वर्षों की संख्या में वर्णन दिया हो।

(२) पति के परदेश-गमन के पश्चात् अतिरिक्त सम्बन्धों से हुए गर्भाधान के काल को स्त्री ने पति-संयोग के काल के समकक्ष रखकर चिकित्सकों को भ्रमित किया एवं वह वर्णन संहिताओं में आ गया।

(३) पौराणिक कथाओं के आधार पर यथा 'शुकदेव मुनि का सोलह वर्ष की अवस्था में जन्म' आदि को वैज्ञानिक आधार देने का आचार्यों ने प्रयत्न किया।

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर उपविष्टकादि के बारे में आधुनिक विज्ञान दृष्ट्या विश्लेषण करने पर प्रसवकाल के वर्णन का विचार नहीं करना चाहिए।

चिकित्सा के वर्णन को देखने से स्पष्ट होता है कि महर्षि सुश्रुत ने सभी विकारों में जीवनीय, वृंहेणीय चिकित्सा के पश्चात् धान्य-कुट्टनादि का विधान बताया है जो गर्भपात कारक है। अन्य आचार्यों ने उपविष्टक या उपशुष्क गर्भ में जीवनीय, वृंहेणीय आदि गर्भवृद्धि-कारक चिकित्सा के पश्चात् यान-वाहनादि का सेवन बताया है जो गर्भपात कारक है। अष्टांगसंग्रहकार ने स्पष्टतया गर्भ के पात करने का निर्देश भी दे दिया है।

उपयुक्त वर्णन को आधार मानते हुए इन सभी व्याधियों का क्रियात्मक क्षेत्र में उपलब्ध व्याधियों से निम्न प्रकार सामंजस्य कर सकते हैं।

योनि से स्रावादित तथा गर्भ एवं कुक्षि की वृद्धि रक्त जाने के लक्षणों के आधार पर उपविष्टक गर्भ को दूसरे त्रैमास का गर्भाश्यान्तर-मृत गर्भ मान सकते हैं। इसमें स्फुरण की प्रतीति स्त्री की मानसिक स्थिति के कारण हो सकती है। गर्भाश्यान्तर गर्भ की मृत्यु के पश्चात् उसके गर्भादक तथा अन्य जलीयांश का शोषण हो जाता है तथा गर्भ एवं स्त्री की कुक्षि का ह्रास होता है अर्थात् उपशुष्क या नागोर उपविष्टक की ही बाद की अवस्था है, एवं दीर्घकाल तक योनि से रक्तस्रावादित के कारण स्त्री की मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है तथा वह वस्तुस्थिति से अज्ञात हो जाने के कारण गर्भ-स्फुरण आदि लक्षणों का अभाव स्पष्ट प्रतीत करने लगती है। लीनगर्भ परिपूर्ण गर्भ या प्रसवकालोत्तर-स्थित गर्भ की गर्भाश्यान्तर मृत्यु का वर्णन है क्योंकि गर्भ के निर्गम मार्ग के स्रोतों का अवरोध प्रसव-काल में ही विकृति करेगा उसके पूर्व नहीं। हो सकता है यह अवरोध समय पर प्रसव न होने दे तथा गर्भ लीन हो जाय।

अन्य गर्भव्यापदों में सुश्रुत संहिता वर्णित गर्भशय्य गर्भस्थ शिशु के भार की कमी तथा गर्भ वृद्धि गर्भस्थ शिशु के भार की अतिवृद्धि का वर्णन है। अष्टांगसंग्रह वर्णित वातोदर उदराघ्नन का वर्णन है तथा भूतहत गर्भ मिथ्या गर्भ या गर्भभ्रम (स्यूडोसाइसिस) को निर्देश करता है।

इन सभी गर्भव्यापदों का आधुनिक विज्ञान वर्णित निम्न स्थितियों से सामंजस्य कर सकते हैं।

गर्भशय्य एवं गर्भशोष	भार-दृष्ट्या अग्रगण्य गर्भ
उपविष्टक	गर्भावस्था के दूसरे त्रैमास में गर्भाश्यान्तर गर्भ मृत्यु
उपशुष्क या नागोर	सुश्रुत मतानुसार गर्भभ्रम एवं गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में गर्भाश्यान्तर गर्भ की मृत्यु, अन्य आचार्यों के मत से अधिक काल तक स्थित गर्भाश्यान्तर मृत-गर्भ
लीन गर्भ	प्रतिभूत या विरकाल-स्थायी गर्भ का स्पन्दनभाव या मृत्यु
गर्भवृद्धि	गर्भ के भार की अधिकता
वातोदर	आघ्नन
भूतहत गर्भ	गर्भभ्रम या मिथ्यागर्भ

It is very difficultly to give exact explanation for all these *upāsūśka* etc. eight disorders. There exists some difference of opinion amongst different authors which is summarized hereunder;

Author	Etiology	Clinical features	Period of delivery	Principles of treatment
Caraka	Bleeding and absence of nourishment.	Desiccation of fetus.	Years.	<i>Jvanyā, vṛṇhanyā</i> and unctuous articles.
Sūśruta	Vitiation of <i>vāṭya</i> .	Desiccation of fetus and absence of filling of uterus, less quickening.	—	Soft, unctuous articles, meat-soup, at the end pestling of paddy.

Author	Etiology	Clinical features	Period of delivery	Principles of treatment
Vāgbhata I	Desiccation of <i>rasavāhī-srotasas</i> by vitiated <i>vāyu</i> .	Small fetus suffering from <i>vāta</i> disorders.	Years	Just like Caraka.
Vāgbhata II —	—	—	—	—
Caraka	Use of hot, pungent articles, bleeding or other vaginal discharges during <i>sañjātasāra garbha</i> .	Absence of fetal growth, prolonged intra-uterine stay.	After considerable delay	<i>Jīvanīya</i> , <i>virñhanīya</i> drugs, egg, riding etc.
Suśruta	—	—	—	—
Vāgbhata I	Due to use of contraindicated articles in <i>sañjā-tasāragarbha</i> , continuous but less bleeding per vagina causing aggravation of <i>vāta</i> and obstruction to <i>rasavāhī-nāḍī</i> .	Absence of abdominal growth, quickening of fetus without decrease in its size, clinical features of other <i>doṣas</i> .	After years.	Just like Caraka lateron induction of abortion
Vāgbhata II	Bleeding in developed fetus.	Just like Vāgbhata I —	—	Just like Caraka
Caraka	Due to dry or other abnormal diet, aggravation of <i>vāyu</i> .	Absence of fetal growth and quickening	After considerable delay.	Just like <i>upaviṣṭaka</i>
Suśruta	Aggravation of <i>vāyu</i> in very early pregnancy	Either decrease in fetal size or being carried away by <i>naigameṣa</i>	—	Soft, unctuous diet, pestling of paddy, riding etc.

Author	Etiology	Clinical features	Period of delivery	Principles of treatment
Vāgbhata I	Just like <i>upaviṣṭaka</i> but excessive bleeding or vaginal discharges	Decreased fetal and abdominal size, very less quickening, clinical features of other <i>doṣas</i> .	Years together	Just like <i>upaviṣṭaka</i> .
Vāgbhata II	Just like Caraka	Desiccation or emaciation of fetus, decreased abdominal size, delayed quickening.	—	Just like <i>upaviṣṭaka</i>
Caraka	—	Absence of quickening	—	Meat soup and massage.
Suśruta	Obstruction to the (exit) passage of fetus due to aggravated <i>vāyu</i> .	Trouble to fetus or its intra-uterine death, its attachment to <i>srotasas</i> .	Very delayed.	Soft, unctuous measures, pestling of paddy, and riding
Vāgbhata I	Affliction of <i>srotasas</i> by <i>vāyu</i> .	Absence of quickening or its over attachment to <i>srotasas</i> .	—	Just like Caraka and to make the woman happy.
Vāgbhata II —	—	Absence of quickening	Years together or no delivery.	Just like Vāgbhata I

Preceding descriptions clearly show that *garbhāśoṣa* or *kṣya* is a condition of underdevelopment of fetus due to inadequate nutrition or intrauterine growth retardation of fetus.

Upaviṣṭaka (not described by Suśruta) is a condition developing fourth month onwards in pregnancy having bleeding per vagina, absence of further development of uterus but presence of quickening of fetus.

Caraka and Vāgbhata II have not specified any gestational age of fetus for *upāśuṣka* or *nāgodaṛa*. Suśruta considers it a diseases of very early gestational age while Vāgbhata I has mentioned that this entity also develops fourth month onwards. Suśruta has incorporated two conditions under this i. e. carrying away of fetus by *naigameṣa* and *nāgodaṛa*. It is just possible that in very early pregnancy due to absence of proper development, the fetal parts could not be detected by the woman during its expulsion, thus she thought that it has been taken away by *bhūtas*, however, when fetus remained in uterus without

proper development, it was termed *nāgodara*.

In *līna garbha* sleepiness or idleness and absence of quickening as clinical features and obstruction to the *srotasas* or (exit) passage of fetus has been described by Suśruta, Vāgbhata I and Dalhana.

Suśruta has not described any condition in which fetus delivers after years together, however he has mentioned delayed intrauterine stay of *līna garbha*. Delivery of fetus after years in certain conditions mentioned earlier has been given by others (of *garbhaśoṣa*, *upaviṣṭāka* and *upaśūṣka* by Vāgbhata I).

Intrauterine stay of any fetus beyond a limit after normal delivery period is not seen in practice. The description might have come up due to following reasons:

- If the woman conceives during lactational or other amenorrhoea period and her period of pregnancy is counted from the day of amenorrhoea then the pregnancy period would appear much prolonged.
- If the woman conceiving by her extra-marital relations after departure of her husband to some other place, misleads the physician by giving her date of pregnancy from the date of her last contact with her husband, then the pregnancy period would seem much prolonged.
- An attempt has been made to rationalise mythological stories as the Śukadeva Muni was born after sixteen years of intrauterine stay.

Considering above facts the period of delivery mentioned in classics should not be given specific cognizance.

In treatment Suśruta has advocated pestling a procedure likely to induce abortion after initial anabolic or general growth promoting treatment in all the conditions. Others have described riding etc. instead of pestling which can also induce abortion after initial general anabolic treatment. Vāgbhata I has specifically indicated the induction of abortion if general measures fail to promote the fetal growth.

Taking into consideration all the aspects these eight fetal disorders can be equated with today's known disorders in following way—

Due to presence of vaginal discharges and arrest of development of uterus the *upaviṣṭāka* may be considered as intrauterine fetal death in second trimester of pregnancy. Feeling or quickening may be due to psychology of woman, as she knows that she is pregnant. After intra-uterine fetal death its fluid portion is absorbed and size of uterus decreases which is *nāgodara* or *upaśūṣka* or in other words *nāgodara* or *upaśūṣka* is a latter condition of *upaviṣṭāka*, by this time the lady understands the reality thus feeling of quickening also diminishes.

Līna garbha is description of intrauterine death of mature or postmature fetus, because the obstruction into the passage (exit) of fetus will produce any abnormality only during period of delivery not before that.

Congruence of these eight diseases with the disorders described in books of obstetrics is given here-under—

Garbhakṣaya or *Garbhaśoṣa*
Upaviṣṭāka

: Under-weight fetus or intrauterine growth retardation.
: Intrauterine fetal death during second trimester of pregnancy.

Upaśūṣka or *Nāgodara*

: According to Suśruta pseudocyesis or intrauterine fetal death during first trimester and according to others missed abortion of second trimester.

Līna Garbha

: Absence of quickening or death of mature or post-mature fetus.

Garbhavṛddhi

: Over-weight fetus or macrosomia.

Vāṭodara

: Flatulence.

Bhūāhṛta or *Divya garbha*

: Pseudocyesis

(१) *जरायुदोष (Jarāyudōṣa)*

विकृत जरायु के द्वारा गर्भ का अञ्छादन जरायु-दोष कहा जाता है। गर्भ के आवेगन रूप विरहित चर्म को जरायु कहते हैं। गर्भाशय में स्थित गर्भ को आवेहित करने वाले जरायु में अल्प विकार होने पर उसे जरायुदोष कहते हैं^१।

Covering of fetus by abnormal *jarāyū* is termed as *jarāyū-dōṣa*, *jarāyū* is the membrane which covers the fetus during its intra-uterine stay.

विमर्श (Comments)

जरायु-दोष के अन्तर्गत जरायु (ऐमनियोन) के सभी विकारों यथा अल्बिनिज्म, शोथ, ग्रान्थि (सिस्ट), पिडिका (नैडोसम) एवं बन्ध आदि के साथ गर्भोदक-आधिक्य एवं गर्भोदक-न्यूनता का भी समावेश कर सकते हैं।

Under this heading all the abnormalities of amnion i. e. unusual friability, amnionitis, cysts, amnion-nodosum, amniotic adhesion alongwith polyhydramnios and oligo-hydramnios can be included.

रक्तगुल्म (Raktagūlma)

पूर्व वर्णित नौ गर्भव्यापदों के अतिरिक्त रक्तगुल्म भी एक ऐसी व्याधि है जो गर्भ से सामंजस्य रखती है, अतः इसका भी वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। सभी आचार्यों ने इसका वर्णन गुल्म के अन्तर्गत किया है^२।

Raktagūlma a disease described alongwith other *gūlmas* stimulates disorders of fetus, hence is being described here.

१. जरायुदोष इति । विकृतजरायुणा छदनं जरायुदोषः । जरायुर्गर्भस्यावेगनरूपविक्रमः । 'जरायुणा मुखे च्छेद' इत्यादि दर्शनात् । अथर्गभस्याया स्थिते यो बालस्तस्योपरि वेदितोत्पत्तिकारत्वाज्जरायुदोष इत्यभिप्रायः ॥ (शां० सं० पूर्व० ७/१८२ को आठ० टीका)

२. (अ) इह खलु पञ्च गुल्मा भवन्ति.....शोणित गुल्म इति । (च० सं० नि० ३/३)

(आ) स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ (सु० सं० ३० ४२/८)

(इ) अर्तस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ॥ (अ० ह० नि० ११/३२)

रक्तगुल्म के स्त्रियों में ही होने का कारण (Cause of its presence only in women)

शोणितगुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य, गर्भकोष्ठार्तवगमनवैशेष्यात् ॥
(च० सं० नि० ३/१३)

...तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ (सु० सं० उ० ४२/८)

रक्तगुल्मस्तु गर्भकोष्ठार्तवगमनवैशेष्यात्तत्प्रादुर्भावश्चातुशोधाच्च स्त्रिया एव भवति ॥
(अ० सं० नि० ११/४४)

...रक्तगुल्मस्तु स्त्रिया एव प्रजायते ॥ (अ० ह० नि० ११/४८)

रक्तगुल्मः स्त्रिया योनौ जायते न नृणां क्वचित् ॥ १४॥ (का० सं० चि० ८)

...स्त्रीणां रक्तगुल्मो हि जायते । तदश्वस्य चाभावात् पुरुषाणां न जायते ॥ १८॥
(का० सं० चि० ९)

शोणितगुल्म या रक्तगुल्म गर्भकोष्ठ अर्थात् गर्भाशय तथा आर्तव के आगमन की विशेषता के कारण स्त्रियों में ही होता है । टीकाकार चक्रपाणित्त ने लिखा है कि आर्तव-प्रतिबन्ध-जन्य रक्तगुल्म पुरुषों में नहीं होता, परन्तु सामान्य शोणित-दुष्टि-जन्य गुल्म पुरुषों में भी होता है, तथा इसे कुमारी एवं वृद्धा में निषिद्ध बताया है अर्थात् यह केवल युवा स्त्रियों में ही होता है कुमारी या वृद्धा में नहीं ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि अन्य (वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के अतिरिक्त) गुल्म रक्त के कारण स्त्रियों में होता है । टीकाकार डल्हण ने भी चक्रपाणि की ही भाँति स्पष्टीकरण दिया है कि धातु-रूप रक्त का गुल्म पुरुषों में भी होता है, इस धातु-रूप गुल्म के लक्षण पित्तज गुल्म सदृश होने के कारण इसका पृथक् वर्णन नहीं दिया गया ।

अष्टांगसंग्रहकार ने महर्षि चरक के समान ही लिखा है कि स्त्रियों में गर्भकोष्ठ या गर्भाशय तथा आर्तव आने की विशेषता, उनके परतन्त्र, अज्ञानी एवं पसेवात (अत्याधिक) होने के कारण रक्तगुल्म स्त्रियों में ही होता है । टीकाकार इन्द्र ने चरक के व्याख्याकार जर्नट (जेन्ट) के मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि जो स्त्री गर्भ-ग्रहण-समय (आयु वाली) होती है रक्तगुल्म उसी को होता है । कन्याओं, तनु-आर्तवा (पतले आर्तव-साव वाली स्त्री) तथा पूर्ण वयस्क (प्राज्ञ या वृद्धा) स्त्रियों को नहीं होता ।

अष्टांगसंग्रहकार ने भी लिखा है कि रक्तगुल्म स्त्रियों में ही होता है ।

महर्षि चरक ने लिखा है कि रक्तगुल्म स्त्रियों की ही योनि में होता है कभी भी पुरुषों को नहीं होता, क्योंकि पुरुषों में उस आशय का अभाव रहता है । स्त्रियों में भी यह कन्याओं को नहीं होता ।

१. आर्तवप्रतिबन्धजन्यः शोणितगुल्मः पुरुषस्य न भवति । सामान्यशोणितदुष्टिजन्यस्तु पुरुषस्यापि भवति ॥
(च० सं० नि० ३/१३ की चक्र० टीका)

२. स्त्रियभित्तनेन कुमारीमतिवृद्धां च निषेधयति ॥ (च० सं० चि० ५/१८ की चक्र० टीका)

३. रक्तेन आर्तवरेकेन; चकारात् धातुरेकेणापि गुल्मो जायते, स च पुंसां स्त्रीणां च भवति; तस्य च पृथगुपादानं न कृतं, वैतनिकगुल्मसमानलक्षणतया तत्रैवावरोधात् ॥ (सु० सं० उ० ४२/८ की डल्ह० टीका)

४. या स्त्री गर्भग्रहणसमयां सैव गृह्यते । न कन्यका प्रतनुकर्तव्या परिणतवयसका चेति चरकव्याख्याने जर्नटः ॥
(अ० सं० नि० ११/४४ की इन्द्र टीका)

५.कन्यानां च न जायते ॥ १५॥ (का० सं० चि० ९)

महर्षि भेल, भावमिश्र, योगतन्त्राकार तथा माधवनिदानकार के भी यही विचार हैं । मधुकोषव्याख्याकार ने कुमारी में अनुदंष्ट्र रज के कारण तथा वृद्धा में रज की क्षीणता के कारण इस व्याधि की अनुस्यूति वर्णित की है^३ । महर्षि शार्ङ्गधर ने रोगों के भेदों की गणना में आठवाँ रक्तगुल्म माना है^४ ।

Raktagulma develops only to the females not to males, because the women possess *garbhāśya* (uterus) and have regular appearance of *ārtava* (menstrual blood or ovum) which is accumulated. It does not develop in young girls or aged women.

Their absence of freedom, ignorance and engagement in service of others is also responsible for development of *raktagulma* (due to above causes she may have to suppress her natural urges which may aggravate *dosas*). Cakrapāṇi and Hindu opine that this disease develops in active reproductive age, neither to the young girls due to absence of menarche, nor to aged women due to menopause, or even to the women having watery menstruation. However *gulma* of *rakta dhātu* can develop even to men.

निदान एवं सम्प्राप्ति (Etiopathogenesis)

महर्षि चरक ने चिकित्सास्थान तथा अष्टांगसंग्रहकार^५ ने निदानस्थान में सामान्य गुल्मों के निदान एवं सम्प्राप्ति का पृथक् उल्लेख किया है । यद्यपि सभी गुल्मों की सामान्य सम्प्राप्ति होने के कारण वह रक्तगुल्म की भी सम्प्राप्ति मानी जा सकती है परन्तु वर्णन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्णन रक्तगुल्म के अतिरिक्त अन्य सभी गुल्मों का है । टीकाकार चक्रपाणि ने यह स्पष्टतया लिखा है कि सामान्य सम्प्राप्ति का वर्णन रक्तगुल्म को छोड़कर अन्य सभी गुल्मों का है^६ । रक्तगुल्म के विशिष्ट निदान एवं सम्प्राप्ति का वर्णन इस प्रकार है-

पातन्यादवैशाराद्यात् सततमुपचातानुरोधेन वैगान्दोर्णानुरन्ध्रतया आगमर्षे वाऽप्यऽधिरथितेऽधवाऽप्य-विप्रजाताया ऋतौ वा वातप्रकोपणान्धसेवमानायाः क्षिप्रं वातः प्रकोपमापाद्यते ॥

स प्रकुरितो योनिमुखमनुप्रविशयतां वमुपफण्डि, मासि मासि तदातं वमुपस्थमानं कुक्षिमभिभवयति ॥

(च० सं० नि० ३/१३, १४)

ऋतावनाहारतया भयेन विरुक्ष्णवैगविनिग्रहैश्च ।

संस्तम्भनोल्लेखयानिदोर्भुम्भः स्त्रियं रक्तभवतोऽप्युपैति ॥ (च० सं० चि० ५/१८)

१. (अ) अध लोहितगुल्मस्तु स्त्रीणमेव प्रजायते ॥ २१॥

नातो(सौ) भवति नृणां तु..... ॥ (शे० सं० नि० ३)

(आ) आर्तवादीषि गुल्मः स्यात्स तु स्त्रीणां प्रजायते । अन्यस्तस्य भवः पुंसां तथा स्त्रीणां प्रजायते ॥ (भा० प्र० चि० ३२/३)

(इ) स्त्रीणामार्तवजो गुल्मो न पुंसां प्रजायते । अन्यस्तस्य भवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसां च जायते ॥ (सौ० १० गुल्मनि०)
(ई) स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ (भा० नि० २८/३)

२. स्त्रीभवत्वे लब्धे स्त्रीग्रहणेन कुमारीमतिवृद्धां च निषेधयति, अनुदंष्ट्रलोपजन्मत्वात्तयोः ॥
(भा० नि० २८/१५ की मधुकोष व्याख्या)

३. रक्तदृष्टमकः ख्यातः..... ॥ (शा० सं० पूर्व० ७/५३)

४. च० सं० चि० ५/६, ७ एवं अ० सं० नि० ११/३५

५.इयं च शोणितगुल्मव्यतिरिक्तानां चतुर्णां सम्प्राप्तिः ॥ (च० सं० चि० ५/६ की चक्र० टीका)

...क्षतं प्रवक्ष्ये ।

नवप्रसूताऽहितभोजनाया या चामार्गं विसृजेदती वा ।
वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं.....॥ (सु० सं० उ० ४२/१३, १४)

तद्वि वर्धमानमन्तर्वर्तमानं (पाठभेद-पुणो प्र०) मशुक्रमशुकं वा जीवहतिं वातलाभ्यासेवमानाया योषितो

गर्भलिङ्गाणि दर्शयदुल्मी भवति तत्र गुल्मविकसितमक्षीत ॥ (अ० सं० प्रा १/१४)

तत्र यदा सा ऋतुमती नवप्रसूता योनिरोगिणी वा वातलाभ्यासेवते तदाऽस्या वायुः कुपितो योन्या मुखमनु-

प्रविश्यात्तवमुपरुपाद्वि । तदुपरुष्यमानं मासे-मासे कुक्षिमभिनिर्वर्तयति ॥ (अ० सं० नि० ११/४५)

ऋतौ वा नवसूता वा यदि वा योनिरोगिणी सेवते वातलाभि स्त्री कुन्दस्तस्याः समीपः ॥ ४१ ॥

निरुणद्ध्यात्तवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितं । कुक्षिं करोति.....॥ ५० ॥ (अ० ह० नि० ११)

दुष्प्रजाताऽप्रार्णं च गर्भमूर्द्धसुधुना । अन्वक्ष्यगर्भकामा च बहुशीतार्तवा च या ॥ १५ ॥

उदावर्तशोला च वातलाभनिवेशिणी । या स्त्री तस्याः प्रकुपितो वातो योनिं प्रवहते ॥ १६ ॥

निरुणद्ध्यात्तवं तत्र मासिकं सञ्चिजोति च । रक्ते च संस्थिते नातो गर्भियमसीति मन्यते ॥ १७ ॥

(का० सं० चि० ८)

विपर्ययात्तादेव तत्रैव तु निजीयते ॥ १७/२ ॥

अनेन हेतुना स्त्रीणां रक्तगुल्मो हि जायते ॥ १८/१ ॥

यदा रक्तवहा रक्तं प्रदोषात्रानुपहते । विमार्गाहोनिमन्वेति (विकृति)स्तेन जायते ॥ २३ ॥

तथैव रक्तगुल्मोऽपि हेतुनाऽनेन जायते । यदा ऋतुमती नातो प्रामान् वेगान् विधारयेत् ॥ २४ ॥

हिवा त्रासादव्यवाद्या वर्तमानाद्योगात् । एवमादिभिरप्यन्यैरुदावृत्तैः प्रकोपितः ॥ २५ ॥

वायुः शोणितमादाय प्रतिस्रोतः प्रपद्यते । गर्भशय्यमुदावृत्तस्तस्या वहति शोणितम् ॥ २६ ॥

मारुतच्युगर्भाया यदा मिश्र्योपचर्यते । तस्याः स वायुरुद्धतः प्रतियतात् सशोणितः ॥ २७ ॥

गत्वा गर्भाशयं रुद्धः स्थिरत्वमुपपद्यते । संवृतं शोणितं तत्र मारुतो विषम गतः ॥ २८ ॥

रजोवहाः समावृत्तः संस्तम्भयति गर्भवती ॥ (का० सं० चि० ९)

परतत्र होने, अज्ञान (वेगवरोधजन्य व्याधियों का अज्ञान) होने, हमेशा कार्य या सेवा में लगी रहने के कारण उत्पन्न हुए वेगों को रोकने से अथवा आमार्णवस्था (अत्यकालीन गर्भधानावस्था) में गर्भपात होने या प्रसव के तुरंत बाद या ऋतुकाल में वात-प्रकोपक आहार आदि का सेवन करने वाली स्त्री को वायु शीघ्र ही प्रकुपित हो जाती है । वह प्रकुपित वायु योनिमुख (गर्भाशयद्वार) में प्रविष्ट होकर आर्तव का अवरोध कर देती है । वह मास मास में रुका हुआ आर्तव कुक्षि का वर्धन करता है ।

पुनश्च महर्षि चार्क ने लिखा है कि ऋतुकाल में भोजन न करने, भय, रस्य आहार-विहार के सेवन, वेगों के अवरोध, स्तम्भन (योनिगत रक्तस्राव में स्तम्भक औषधियों के प्रयोग) एवं लेखन (योनिरोगों में गर्भाशय लेखन) औषधियों के प्रयोग तथा योनिरोग या अन्य योनिव्यापदों के कारण स्त्रियों में रक्तगुल्म हो जाता है ।

महर्षि सुश्रुत ने संक्षेप में वर्णन करते हुए लिखा है कि अब क्षतज अर्थात् आर्तवरक्तज^१ गुल्म का वर्णन करेंगा । नवप्रसूता, आमार्ग का पात होने के बाद (षट्मास तक के गर्भपात के बाद)^२ अथवा ऋतुकाल में जो स्त्री अहित भोजन का प्रयोग करती है ; (प्रकुपित) वायु उसके रक्त को ग्रहण कर या रोक कर गुल्म उत्पन्न कर देती है ।

१. योनिमुखमिति गर्भाशयद्वारम्.....॥ (च० सं० नि० ३/१३ की चक्र० टी०)

२. क्षतजवन्देर्जातकमुच्यते, कारणे कार्योपचारात् । आमार्गः, षण्मासं यावत् ॥ (सु० सं० उ० ४२/१३, १४ की इल्ह० टीका)

अष्टांगसंग्रहकार ने लिखा है कि वह अन्तर्स्थित (निषिक आर्तव रूपी रक्त) शुक्र के साथ मिलकर जीवहति अथवा त्रिपा शुक्र के भी (अर्थात् अकेले ही) बढ़ता हुआ, वात-वर्धक आहार सेवन करने वाली स्त्री में गर्भ के लक्षण प्रकट करने लगता है, वह गुल्म होता है, इसमें गुल्म की चिकित्सा करें (उपर्युक्त वर्णन वात-कफ से मार्ग के आवृत हो अर्थात् हो जाने पर उसकी पित्तल औषधियों से उपचार के बाद दिया गया है) । पाठभेद में "तद्वि वर्धमानमन्तर्वर्तमाना"^१ वर्णन अधिक मिलता है जिसकी टीका करते हुए टीकाकार इन्दु ने लिखा है कि वह (पित्तज-उपचार आदि से) रक्त बाहर न निकलकर महास्रोतस् के अन्दर जाकर निषिक (योनि में) शुक्र के साथ मिलकर अथवा अकेला ही वर्धन करता है^२ । पुनश्च लिखा है कि यदि ऋतुमती, नवप्रसूता या योनिरोग से पीड़ित स्त्री वात-प्रकोपक आहार-विहार का सेवन करती है तो उसको प्रकुपित वायु योनिमुख में प्रविष्ट होकर आर्तव का अवरोध कर देती है । वह रुका हुआ आर्तव प्रतिमास कुक्षि का वर्धन करता है ।

अष्टांगहृदयकार ने भी लिखा है कि जब नवप्रसूता, ऋतुमती अथवा योनिरोग से पीड़ित स्त्री वातल आहार-विहार का सेवन करती है तो वायु प्रकुपित होकर योनि में आर्तव का अवरोध कर देती है, वह प्रतिमास में स्थित या रुका हुआ आर्तव कुक्षि का वर्धन करता है ।

महर्षि काश्यप ने इस व्याधि का अत्यधिक विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा है कि जो स्त्री दुष्प्रजाता (विकृत प्रसव वाली), आमार्ग (आमार्ग) या एक से तीन माह तक के गर्भाधान वाली, गर्भबू (गर्भस्राव-रुक्त), बहुत मैथुन करने वाली, गर्भ की बहुत ज्यादा इच्छा करने वाली, अत्यधिक शीतल आर्तव वाली, उदात्त से युक्त तथा वात-प्रकोपक आहार-विहार का सेवन करने वाली है, उसकी वायु प्रकुपित हो योनि को प्राप्त होकर आर्तव का अवरोध कर देती है एवं वह (आर्तव) प्रतिमास संचित होता जाता है । रक्त के स्थित होने के कारण स्त्री अपने आपको गर्भिणी मानने लगती है । पुनश्च महर्षि काश्यप लिखते हैं कि विपर्यय होने (अर्थात् पुण्यभूत हो प्रतिमास प्रवर्तित न हो सकने) के कारण वह आर्तव वहीं अर्थात् गर्भाशय में ही एकत्र हो जाता है एवं इस कारण से स्त्री को रक्तगुल्म होता है । जिस प्रकार दोषों से टुट होने पर रक्त (आर्तव) रक्तवहा-सिराओं में न जाकर विपरीत मार्ग से योनि में पहुँच कर विकार उत्पन्न करता है उसी प्रकार उपर्युक्त कारण से अर्थात् रक्त के दोषों से दूषित होने से रक्तगुल्म भी हो जाता है । जब ऋतुमती स्त्री लज्जावश, भयवश अथवा व्यवथा या मैथुन में संलग्न होने के कारण अधोभाग के प्रास (मल, मूत्र, अपान वायु) हुए वेगों का धारण करती है, तब अथवा उदात्त आदि अन्य कारणों से वायु प्रकुपित हो जाती है । वह प्रकुपित वायु रक्त को लेकर स्रोतस् या गर्भाशय में पहुँचती है । वह उद्वृत वायु गर्भाशय में शोणित को रोक देती है या स्थिर कर देती है । जिस स्त्री का गर्भपात वायु की विकृति के कारण हुआ है उस स्त्री की मिश्र्योपचार के कारण प्रकुपित वायु शोणित को लेकर उद्वृत हो कर गर्भाशय में (ऊपर की ओर) जाकर स्थिरता को प्राप्त हो जाती है (वायु के विकार के कारण शोणित गर्भाशय में रुक जाता है) । वह विषम वायु के कारण रुका हुआ शोणित गोलाकार होकर रजोवहा धमनियों का आवरण करके गर्भ के सदृश स्थिर हो जाता है ।

महर्षि भेल ने भी लिखा है कि हला ही में गर्भस्राव अथवा प्रसव होने या अतिप्रजनन या अप्रजनन होने या भाववहन के कारण रक्त का (वायु के द्वारा) आध्वापन हो जाता है, रक्त के स्थित हो जाने के कारण स्त्री अपने को गर्भिणी मानती है^३ ।

१. इन्दुटीका की पुस्तक में वर्णित पाठभेद ।

२. यतस्तरक्तं बहिःप्रवर्तमानमन्तर्वर्तमानसि निषिकशुक्लसहितं केवलमेव वा वर्धते ॥ (अ० सं० प्रा० १/१४ की इन्दु टीका)

३.तस्य वक्ष्यामि लक्षणं । अचिरच्युते गर्भे सूतिकायास्तथा (५) चिरात् ॥ २२ ॥

अतिप्रजननद्विपि तथा (५) प्रजननेन वा । सन्धारणद्विपा (पा) रस्य रक्तमाध्वापयेत्ततः ॥ २३ ॥

सशोणिते स्थिते नातो गर्भयोनि स्त्रीति मन्यते ॥ २४ ॥ (धे० सं० नि० ३/२२ से २४) ।

आचार्य भगवति, माषव तथा योरोरनकार ने गर्हण सुश्रुत के वर्णन का अक्षरशः पालन किया है^१। आचार्य भगवति एवं मधुकोषव्याख्याकार ने आचार्य से नवम मास के पूर्व का प्रसव माना है तथा रक्तगुल्म के आकार को गुटिकाकार वर्णन करते हुए आहार के साथ विहार को विकार मानकर चरक वर्णित "क्लान्तनाहारता"^२... आदि श्लोक भी उद्धृत किया है^३।

General etiopathogenesis described for all types of *gulmas* is not to be considered here. Cakrapāṇi has very clearly mentioned that this general etiopathogenesis does not apply for *raktagulma*. Specific etiopathogenesis is given here-under.

The woman who suppresses her natural urges due to absence of freedom, ignorance and engagement in service of others and uses *vāta* aggravating diet or mode of life during *āmagarbhā* (pregnancy of very short duration), immediately following abortion, delivery or *āmagarbhā* (pregnancy of very short duration), her *vāyu* gets aggravated very quickly. This aggravated during *rūkālā* (menstrual period), her *vāyu* gets aggravated very quickly. This aggravated during *rūkālā* (menstrual period), her *vāyu* gets aggravated very quickly. Every *vāyu* entering *garbhāśayadwāra* (cervix uteri) obstructs the *ārava* (menstruation). month accumulated this *ārava* causes development of *kukṣi* (uterus). Fasting during *rūkālā*, fear, use of dry dietetics and mode of life, suppression of natural urges, use of *stambhaka* (causing cessation of bleeding per vaginam) and *lekhana* (causing medicinal curettage of uterus) drugs and *yoniḍoṣa* (gynecological disorders) also are causative factors for *raktagulma*.

Suśruta has held responsible only use of improper diet during *rūkālā*, after abortion or delivery as a causative factor.

Vāgbhaṭa I says that the woman who uses *vāta* aggravating diet, her *ārava* getting admixed with excreted *śukra* but with absence of *jīvātmā* or sometimes even without *śukra* gets accumulated, increases and gives clinical features of pregnancy, this entity is *gulma*. Further both the Vāgbhaṭas have mentioned use of *vāta*-vitating diet following delivery, during *yoniḍoṣas* and *rūkālā* as etiology of *raktagulma*.

Kāśyapa giving detailed account of etiology says that the woman who has had abnormal labour, is carrying *āmagarbhā* (pregnancy of early first trimester), has had abortion, indulges in excessive coitus, is over anxious to become pregnant, has excessively cold *ārava* (menstruation), suffers from *udāvarta*, if uses diet or mode of life capable of vitating *vāta*, then her *vāyu* gets aggravated. When the woman due to shyness, fear or being engaged in coitus suppresses her urge of defecation, urination or passing of flatus then also her *vāyu* gets aggravated. If the woman who has had abortion due to abnormality of *vāyu* and further uses improper mode of life and diet then also her *vāyu* gets vitiated. This aggravated *vāyu* withholding *rakta*, moving upwards, entering *yoni*, reaches the *śrotasā* or *garbhāśaya* (uterus). There it settles down with *rakta* or *ārava* inside the uterus, thus the

१. नवप्रसूता...कोति गुल्मं...। (सु. सद्गु) (भा० प्र० वि० ३२/१७; भा० वि० २८/१५, एवं यो० २० गुल्म०-चा०ऽमर्ष०-पाठ है)

२. (अ) आचार्य विष्णुवेदिनि। नवममासादवर्क प्रसूतेः। अहित भोजनेति सम्बन्धः। एतन्नोपलक्षणात्,

तेनहारोचारादिकं ज्ञेयम्। यदाह चरकः क्लान्तना...। (च० सं० सद्गु)। (भा० वि० २८/१५ की मधुकोष टीका)।

(आ) या चामर्ष विष्णुवेदेन नवममासादवर्क प्रसूतेः। भोजनपरं विहारस्याप्युपलक्षणं। यदाह चरकः ...।

क्लान्तनाहारता...। (च० सं० सद्गु) (भा० प्र० वि० ३२/१७ की व्याख्या)

ārava which would have otherwise been excreted every month is not discharged. This obstructed *śonita* assuming a rounded shape enveloping *rajovahā dharmāns* stays in uterus just like a fetus.

In *Bhelasamhiā*, *Bhāvayaprakāśa*, *Mādhavanidīna* and *Yogaratanākara* also almost similar ideas have been expounded.

पूर्वलप (Prodromal symptoms)

आचार्य ने रक्तगुल्म के विशेष पूर्वलपों का वर्णन नहीं किया, परन्तु सामान्य गुल्म में होने वाले पूर्वलप इस गुल्म के भी पूर्वलप होंगे। सभी आचार्यों ने सामान्यतया पाचन-संस्थान सम्बन्धी लक्षण पूर्वलप में वर्णित किए हैं जैसे अन्न की अग्निलाभा न होना, अस्ति, अविपाक, अग्निवैषम्य, खाने के बाद जलन, भोजन की पक्कावस्था में छर्दि, उद्गार, वात, मूत्र एवं पुरीष आदि वेगों का उत्पन्न न होना, उत्पन्न होने पर इनका न निकलना, वातजन्य शूल, आटोप, आन्तकजन, रोमांच, उदवर्त, अनुभूषा, दोर्बल्य तथा तृप्तिपुक्त भोजन का सहन न होना आदि सभी गुल्मों के सामान्य पूर्वलप हैं^१।

Since specific prodromal symptoms of this condition have not been described separately, hence general prodromal symptoms described for all the types of *gulmas* should be considered here also. These are—absence of desire and taste of food, indigestion, abnormal appetite and digestion, burning sensation after ingestion of food, vomiting during digestion of food, eructation, absence of urge for passing the flatus, urine and stool or if urge is felt these are not excreted, pain due to effect of *vāyu*, distension of abdomen, sound and pain in bowels, horripilation, upward movement of gases, anorexia, weakness and intolerance for satiating food etc.

लक्षण (Clinical Features)

...मासि मासि तदावतमुपपन्नमयानं कुक्षिमभिचर्धयति।

तस्याः शूलकासातीसारच्छदीवकाविपाकाङ्गमदीन्द्रालस्यरौमित्वकफप्रसेकाः समुपजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यम् ओष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च काण्ठ्यम्, अत्यर्थं नलानिश्चुष्योः, मूर्च्छा, ह्रस्वता, दोर्बलः, श्वयशुश्च पादयोः, ईषच्चोद्गमो रोमनाद्याः, योन्याश्चातलत्वम्, अपि च योन्या दीर्गव्यमात्रावक्षोपजायते, केवलशरास्या गुल्मः पिण्डित एव सन्त्यते, तामागर्भा गर्भिणीमित्याहुर्मूढाः। (च० सं० नि० ३/१४)

यः सन्त्यते पिण्डित एव नाङ्गैश्चित् सशूलः समगर्भिलङ्घः।

स रौधिरः स्त्री भव एव गुल्मो॥ (च० सं० वि० ५/१९)

.....सरुजं सदाहं।

धैरस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध।

न सन्त्यते नोदरयोर्नि वृद्धिं भवन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनाम् ॥ (सु० सं० उ० ४२/१४, १५)

...तदुपपन्नमयानं मासे मासे कुक्षिमभिचर्धयति गर्भलिङ्गानि च ह्रस्वसतन्त्राङ्गसदाहंरौमित्वस्तन्य-दशनादीनि। वायुसंसर्गात्तुनः पित्तैकप्रकोपतया च वातपित्तगुल्मरूपाणि क्रमाच्छूलस्तन्यदाहतीसारदीनि गर्भाशये च सुततां शूलं तथा योन्या दीर्गव्यमात्राव च करोति। गुल्मश्च न गर्भ इवङ्गैः पिण्डित एव तु विशेषेण सशूलं सन्त्यते। गुल्म एव च वर्धते न कुक्षिः। (अ० सं० नि० ११/४५)

१. च० सं० नि० ३/१५, सु० सं० उ० ४२/१८, १९, अ० सं० नि० ११/३८।

..... प्रतिमासमवस्थितम् । कुक्षि करोति तदग्रांभितद्विमाविक्रमोति च ॥५०॥
 हृस्मस्यदौहदस्यदर्शनं क्षामतादिकम् । क्रमेण वायुसंसागिततथोक्तिया च तत् ॥५१॥
 शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोद्युग्मजन्तम् । स्मस्तस्यादाहातीसारतृड्-च्चादीनुपव्रतन् ॥५२॥
 गर्भाशये च सुतरां शूलं दृष्टुमशक्यम् । योऽप्यश्व सार्वदैर्गन्धर्वोदस्यन्मनवेदनाः ॥५३॥
 न चाङ्गैर्गन्धर्वदुःखः स्फुरत्यपि तु शूलवत् । पिण्डीभूतः स एवास्याः कदाचित्समन्ते चिरात् ॥५४॥
 न चास्या वधेति कुक्षिगुल्म एव तु वर्धते ॥५५॥ (अ० ह० नि० ११/५० से ५५)
 स्तनमण्डलकृष्णत्वं रोमगन्धिः सरोहदा गर्भिणीरूपव्यक्तं भजते सर्वमेव तु ॥१८॥
 द्वि अ) प्राकपाण्डुकारशयीनि भवन्त्यभ्यधिकानि तु। इत्येवं लक्षणं स्त्रीणां रक्तगुल्मं प्रवक्षते ॥१९॥
 (का० सं० चि० ८)

स गुल्मः स्यन्दतेऽभीक्ष्णं मारतेन समीरितः ॥२१॥

दर्शयन् यानि रूपाणि तानि वक्ष्यामि सर्वशः । कासते शूल्यते चैव च्यवतेऽथातिसार्यते ॥३०॥
 मय्यते सर्वगत्राणि मूर्च्छितानि गुरुणि वा तमोऽस्या जायतेऽभीक्ष्णं कार्यं चैव निगच्छति ॥३१॥
 वमन्यभीक्ष्णशो भुक्तमन्नं चास्यै न रोचते जायते चोदरे पाण्डा नीलं चास्याः प्रदुश्यते ॥३२॥
 स्तनान्तरे च नाभिश्च लोमाजो च मूर्च्छिता ओष्ठौ च कृष्णौ भवतस्तथैव स्तनच्यवतौ ॥३३॥
 पयोधरे प्रसिच्यते दोहदं च निगच्छति । नानासात् प्रार्थयते निश्चिवति मधुर्मुहः ॥३४॥
 शुभादुद्विचते गन्धाद्वर्णशस्याः प्रसीदतां गर्भिण्या यानि रूपाणि तानि संदृश्य तत्ततः ॥३५॥
 वर्षाणि हस्ति व्याधिं गर्भोऽयमिति दुःखिता ॥३६॥ (का० सं० चि० ९)

प्रत्येक मास में रक्ता हुआ वह आर्तव कुक्षि (उदर) का वर्धन करता है । उस स्त्री को शूल, कास, अतिसार, छर्दि, अरोचक, अविषाक, अंमर्द, निद्रा, आलस्य, स्तौम्य (जड़ता सी) तथा कफप्रसेक (मुख में पानी या कफ सदृश आना) आदि लक्षण हो जाते हैं । स्तनों में सत्य की उत्पत्ति, ओष्ठ एवं स्तनमण्डल की कृष्णता, नेत्रों में अत्यधिक नयानि (शकावट), मूर्च्छा, हृस्मस (जो भिचलाना), दौहद, पैरों में शोथ, रोमजो की ईर्षा उदगम, योनि-विस्तार तथा योनि से दुर्गन्धित स्राव आदि उत्पन्न हो जाते हैं । पिण्ड के समान केवल गुल्म ही स्यन्दन करता है, उस अमर्षा या गर्भ-रहित स्त्री को अज्ञानो लोग गर्भिणी कहते हैं । टीकाकार चक्रपाणि ने सत्य की उत्पत्ति का कारण अर्तवशेष से उत्पन्न इस व्याधि का स्वभाव माना है तथा गुल्म में चेतना के अभाव में दौहद की उत्पत्ति का कारण अर्तव-जन्य गर्भ-प्राप्ति माना है एवं लिखा है कि जिस प्रकार विष-पान की शंका होने पर ही व्यक्ति को विष के लक्षण हो जाते हैं उसी प्रकार अर्तव के कारण स्त्री को दौहद की प्रतीति होती है । पिण्डाकार स्यन्दन के स्मष्टीकरण में लिखा है कि गुल्म में केवल स्यन्दन होता है एक देश या एकांग से नहीं जब कि गर्भ एक देश या एकांग से भी स्यन्दन करता है^१ ।

महर्षि चक्र ने पुनः लिखा है कि जो पिण्ड रूप में न कि अङ्गों से, शूल के साथ तथा चिरकाल में स्यन्दन करता है, गर्भ के लक्षणों वाला वह स्त्री को ही होने वाला रक्तगुल्म है ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि इस गुल्म में पीड़ा तथा दाह होता है एवं सामान्य रूप से इसमें पैतृक गुल्म के सदृश अर्थात् स्वेद, ज्वर, आहार का पाक न होना, दाह, तुषणा, अङ्गवेदना, मुख में कटुआमन आदि अन्य पित्त के लक्षण होते

१. । स्तनयोः सत्यमिति रोमाभावादेव बोद्धव्यम् । अर्तवशेषलक्षणास्य व्याधेर्य प्रभावो यत् सत्यं करोति ... । शोणितगुल्मे च चेतना नास्ति, तेन नैवरूपमिह द्रैव्यं दोहदम् । तेन गर्भान्तरा यत्किंचिदभ्यवहारेच्छादिलक्षणं दोहदं तस्या भवति, असत्यपि विषमस्यन्मे यथा शङ्खनिषाद्विषलक्षणं भवतिः..... । केवलः स्यन्दत इति नैकदेशेन, गर्भो ह्येकदेशेनापि स्यन्दते । (च० सं० नि० ३/१४ की चक्र० टीका)

२. स्वेदच्चादाहादीहदपाण्डुकाङ्गाः कटुचकला च । पित्तस्य लिङ्गान्धिलानि यानि पितात्मके तानि भवन्ति गुल्मे ॥ (सु० सं० उ० ४२/११)

है विशेष कर इसमें स्यन्दन नहीं होता और न ही उदर की वृद्धि ही होती है, एवं गर्भिणी के सदृश (गर्भावस्था जन्य गर्भिणी-लक्षण) लक्षण होने हैं । टीकाकार डक्टर ने 'न स्यन्दते' का स्मष्टीकरण करते हुए लिखा है कि वह गुल्म अंगों से अर्थात् गर्भ को भाँति अलग-अलग अंगों से स्यन्दन न करके पिण्डवत् स्यन्दन करता है, अन्य लोगों के मत का उद्धरण देते हुए लिखा है कि 'न' या निषेध का दोनों ओर अर्थात् स्यन्दन एवं उदर वृद्धि के साथ सम्बन्ध होने के कारण स्यन्दन होता है ऐसा सम्झना चाहिए, अन्य गर्भ सदृश श्रम आदि लक्षणों की उत्पत्ति इस व्याधि के स्वभाव के कारण मानी है^१ ।

अष्टांगसंग्रहकार ने लिखा है कि वह प्रत्येक मास में रक्ता हुआ आर्तव कुक्षि को धीरे-धीरे बढ़ता है एवं हृस्मस, तन्त्रा, आंसाद, दौहद तथा सत्य-दर्शन आदि गर्भ के लक्षणों को करता है । वायु के संसर्ग के पश्चात् पित्त का प्रकोप होने पर वातपित्त गुल्म के रूप क्रमशः शूल, सत्स्य, दाह, अतिसार, गर्भाशय में अत्यधिक शूल तथा योनिमार्ग से दुर्गन्धित स्रावों का निकलना आदि लक्षण होते हैं । गुल्म, गर्भ के सदृश अङ्गों से स्यन्दन न करके पिण्ड रूप में, चिरकाल से तथा शूल के साथ स्यन्दन करता है । गुल्म ही वृद्धि को प्राप्त करता है कुक्षि नहीं ।

अष्टांगहृदयकार ने शब्दभेद से उपर्युक्त सदृश ही वर्णन किया है कि प्रतिमास कुक्षि में रक्ता हुआ आर्तव हृस्मस, दौहद, सत्यदर्शन तथा क्षामता (कुशला) आदि गर्भ के लक्षणों को करता है । क्रमशः वात के साथ पित्त का संसर्ग होने पर उस रक्तगुल्म में वातपित्तज गुल्म के लक्षण यथा वेदना, सत्स्य (रक्तावट सी या जड़ता), दाह, अतिसार, तुषणा एवं ज्वर आदि उपर्युक्त होते हैं । दूषित आर्तव का आश्रय होने के कारण गर्भाशय में अत्यधिक शूल, योनि से स्राव, दुर्गन्धि, तोद (सुई चुपने सी वेदना), स्यन्दन (थोड़ा थोड़ा लगातार स्राव) तथा वेदना होती है । गुल्म, गर्भ के सदृश अंगों से स्युरण नहीं करता, वह शूल के साथ पिण्डाकार में ही, चिरकाल के पश्चात्, कभी कभी स्यन्दन करता है इसमें कुक्षि का वर्धन नहीं होता गुल्म ही बढ़ता है ।

महर्षि काश्यप ने विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए लिखा है कि स्तनमण्डल में कृष्णता होना, रोमगन्धि की उत्पत्ति, दौहद तथा अव्यक्त (अस्यष्ट) रूप से गर्भिणी में होने वाले सभी लक्षण होते हैं, विशेष कर अपचन, पाण्डु, कार्य अधिक होते हैं ये लक्षण स्त्री के रक्तगुल्म के हैं । वायु के कारण वह गुल्म अत्यधिक स्यन्दन करता है एवं उसके जो अन्य रूप दिखाई देते हैं उन सभी को मैं विस्तार से कहूँगा । स्त्री को कास आती है, शूल होता है, ज्वर तथा अतिसार होता है । वह अपने सभी शरीर के अंगों को मूर्च्छित (संज्ञा विहीन सा) एवं गुरु प्रतीत करती है । उसे अत्यधिक अंशकार प्रतीत होता है, कृश हो जाती है, अत्यधिक वमन होता है, खाया हुआ अन्न खींचकर नहीं लगाता, उदर में ग्रन्थियाँ हो जाती हैं; स्तनान्तर तथा नाभि प्रदेश (में नीले धब्बे) एवं रोमरजि नीले से दिखाई देते हैं, वह मूर्च्छित हो जाती है । ओष्ठ एवं स्तनच्युक्त कृष्ण हो जाते हैं, स्तनों से दुग्ध निकलता है, उसे दौहद होता है, वह अनेकों प्रकार के रसों (रस या स्वाद वाले खाद्य पदार्थों) की इच्छा करती है । बारम्बार निष्ठिवन करती है, शुभ या अच्छी गन्ध से उद्विग्न या परेशान हो जाती है । उसका वर्ण प्रसन्न हो जाता है (अर्थात् निखर आता है) एवं अन्य सभी गर्भिणी के लक्षणों को ध्यान में रखकर गर्भ है ऐसा समझते हुए कष्ट पूर्वक इस रोग को वर्षों तक ढोती है । कदाचित् काल के परिणाम से यदि गुल्म का भेदन हो जाता है तब उस रक्तस्राव में गर्भ की अनुपस्थिति से स्थिराँ उसे दिव्य गर्भ या भूतहन्त-गर्भ आदि कहने लगती है^२ ।

महर्षि भेल ने लिखा है कि इस व्याधि में कुक्षि में शूल होता है । कोष्ठ में गुल्म होने के कारण स्त्री उदर में गर्भ मानकर अपने आपको गर्भिणी मानती है । गर्भ मानकर वह स्त्री इस व्याधि को एक या अनेकों वर्षों तक धारण किए रहती है, कभी कभी यह गुल्म भाग्यवश भेदन को प्राप्त हो जाता है । कुछ समय के पश्चात् (अपने आपको गर्भिणी मानने के कुछ काल पश्चात्) उसके स्तन क्षीर-युक्त हो जाते हैं, वह कृश हो जाती है, उसे पाण्डुता तथा दौहद की वस्तुओं की

१. न स्यन्दते न चलति, अङ्गैः इति शेषः । अन्ये तु पत्तो निषेधस्योपपन्न सम्बन्धात् स्यन्दते इत्येव वर्णयन्ति ।

..... गर्भिणीनां लिङ्गानि श्रमादीनि सदृजान्तास्य व्याधिस्वभावाद् भवन्ति । (सु० सं० उ० ४२/५५ की डक्टर टीका)

२. का० सं० चि० ९/३६ से ४० (पृष्ठ ३७६, ३७७)

आकांक्षा होती है। जर्दं, निश्चिन्ता, तन्द्रा तथा थैलें में शोथ आदि रक्तगुल्ल में विकार हो जाते हैं।^१

आचार्य भगवामिश्र, योगरत्नाकर तथा माधव ने इसे पित्तगुल्ल के सदृश लक्षणों वाला, गर्भ के समान अङ्गों अङ्गों से समन्वय न करके पिण्ड रूप में, विकृताकार के बाद शूल के साथ समन्वय करने वाला वर्णित किया है।^२

मधुकोष व्याख्या एवं भगवत्प्रकाश की टीका में स्पष्ट किया है कि गर्भ के समान लक्षण लिखने का तात्पर्य गर्भ के समी लक्षणों तथा अर्तव का दर्शन न होना, मुख का पीलापन एवं मुखसाव, स्तनमुख की कृष्णता एवं दोहद से है। ये सभी लक्षण रक्तगुल्ल अर्थात् अर्तव रूपा रक्त के गुल्ल में व्याधि के स्वभाव के कारण उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार स्त्री व्याधि में स्त्री-प्रसङ्ग की इच्छा तथा अर्श में त्वचा एवं नखों की कृष्णयता है।

The *ārava* accumulated every month produces development of *kukṣi* (uterus). The woman suffers from colic, cough, diarrhoea, vomiting, anorexia, indigestion, bodyache, sleepiness, indolence, feeling of stillness and excessive salivation. Milk appears in her breasts, lips and areola become black; she feels heaviness in eyes or drooping of eyelids, suffers from unconsciousness and nausea; gets feeling of *dohṛda*, edema of feet, presence of faded *romarājī* (linea nigra), dilatation of *yoni* (vaginal canal) and foul smelling vaginal discharges. *Gulma* quivers just like a solid mass not from different body parts and quivering starts comparatively late.

Suśruta says that generally in this *gulma* there is pain, burning sensation and other clinical features of *patitika gulma* such as perspiration, fever, indigestion, burning sensation, thirst, bodyache, bitter taste of mouth etc. Neither there is quivering nor development of abdomen, however, the woman has all the symptoms of pregnancy. Dalhaṇa explains that *gulma* quivers slowly like a solid mass.

Both the Vāgbhāṭas describing the presence of clinical features of pregnancy such as nausea, drowsiness, bodyache, emaciation, *dohṛda* and milk secretion, besides the development of *kukṣi* due to accumulation of *ārava*, have elaborated further that after initial association of *vāyū* followed by aggravation of *pitta* the features of *vāṭapitṭaja gulma*

१. स(आ)मया(द)ध शूलानि तस्याः कुक्षौ भवन्त्यथ ॥ २४॥

कोष्ठे गुल्मोदरे तच्च गर्भोऽयमिति मन्यते। गर्भोऽयमिति च व्याधिवर्धमेकं बहुव्ययि ॥ २५॥

भारयत्यथ निर्भेदं कथंचित्संन्यच्छति। अथास्याः कालपर्यायात् संक्षीरे भवतः स्तनौ ॥ २६॥

कृशा भवति ना(चा)पाण्डुरो(ह)दं चाभिनन्दति। छद्विनिश्चीविका चैव तत्रा चैव प्रबाधते ॥ २७॥

पादयोः श्वयथुश्च स्यात्कगुल्मे प्रवृत्ति ॥ २८॥ (धे० सं० नि० ३/२४ से २८)

२.संलभ्य सदाहम्। वैतस्य लिङ्गेन समानलिङ्गे विशेषणं चाप्यर्थं निबोध।

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गीक्षितसमूह समभिलिङ्गः ॥ स रौघिः स्त्रीभव एव गुल्मो।

(धो० प्र० वि० ३२/१७, १८; धो० १० गु० नि०-धो० प्र० सदृश)

...सर्वत्र सदाहम् ॥ पित्तस्य गुल्मेन ...। ...समूह... ॥ गुल्मो... ॥ (धो० १० गु० नि०-धो० प्र० सदृश)

३. (अ) समगर्भलिङ्ग इति। अर्तवदर्शनमुखकृष्णत्वदोहदौर्गर्भलक्षणयुक्तं, एतच्च व्याधिप्रभावात्; यथा

क्षयार्थतोः स्त्रीरिरसाकृष्णत्वान्नादयः ॥ (धो० नि० २८/१६ की मधु० टी०)

(आ) समगर्भ लिङ्गः अत्र समग्रान्दः सर्वशब्दार्थः, तेन समाभि-सर्वाणि, गर्भलिङ्गानि-अर्तवप्रवृत्तिकाले 'अर्तवदर्शनमुख-पीतला-स्तनमुखकृष्णता-दोहदौर्गर्भ' यत्र सः। एते च व्याधिप्रभावात् यथा यक्षिणो रिसा। सतीधरः-अर्तवरूप-

रक्तजाः - ॥ (धो० प्र० वि० ३२/१८ की टीका)

appear. These are—colic, stiffness of body, burning sensation, diarrhoea, thirst and fever. Due to retention of abnormal or vitiated *ārava* the woman suffers from severe pain in uterus, continuous but scanty vaginal discharges specially foul smelling and severe pain specially of pricking type in vagina, quivering is of solid mass, delayed, occasional and with pain. Actually there is development of only *gulma* not of *kukṣi*.

Kāśyapa opines that due to association of *vāyū* there is excessive quivering in *gulma*. The woman suffers from indigestion, anaemia, emaciation, cough, colic, fever and diarrhoea. She feels as if all the body parts are numb and heavy and she is entering in dark. She suffers from excessive vomiting, does not feel taste of food, glands appear over the abdomen, breasts and umbilical region and *romarājī* appears blue. She becomes unconscious. Her lips and areola become black, milk appears in breasts, gets *dohṛda*. She desires articles of various tastes, spits repeatedly and gets agitated with good smells. Her complexion becomes better and she gets all the clinical features of pregnancy. Considering her self pregnant carries the disease for years together with great agony. Some times due to time factor if *gulma* is expelled, then due to absence of fetal parts women call it *divya garbha* (divine fetus) or say that fetus is taken away by *bhūās*.

Bhela has followed Kāśyapa and Mādhavanidāna, Bhāṇḍaparakāśa and Yogaratanākara have followed Caraka, however, these authors have given very short description.

In the commentary of Madhukosa and Bhāṇḍaparakāśa it is explained that all the clinical features i.e. amenorrhoea, yellowishness of face, watering of mouth, blackening of areola and *dohṛda* etc. are present in the *raktagulma* or the *gulma* developing due to a type of *rakta* i.e. *ārava*. The presence of these clinical features is due to specific nature of disease in the same way as sexual desire in tuberculosis and dark colouration of skin and nails etc. in piles are seen.

रक्तगुल्ल में गर्भवत् चेष्टा का कारण (Cause of resemblance of raktagulma with fetus?)

गर्भवच्छेष्टे नायं किन्तु सादृश्यदर्शनात् ॥ ४१॥

गर्भोऽयमिति मन्वाना मनसा तद्विश्वाविनी। नारी विचेष्टे तास्ता गर्भचेष्टाः पृथग्विधाः ॥ ४२॥

(का० सं० छि० ९)

यद्यपि यह (रक्तगुल्ल) गर्भ के सदृश (अङ्गों अङ्गों से) चेष्टा नहीं करता परन्तु गर्भ से समानता दिखाई देने के कारण एवं गर्भ ही है इस प्रकार की मन में भावना होने के कारण स्त्री गर्भिणी के सदृश नाना प्रकार की चेष्टायें करती रहती है।

टीकाकार उल्लेख ने गर्भवत् चेष्टा या गर्भिणी के लक्षणों की उत्पत्ति का कारण इस व्याधि का स्वभाव माना है (पृष्ठ ३९५)।

Though *raktagulma* does not behave (does not quiver from different body parts) like fetus, however, due to resemblance with fetus and psychological feeling of being pregnant, the woman behaves as if pregnant. Dalhaṇa says that presence of clinical features simulating pregnancy is specific character of the disease.

रक्तगुल्म में दौहद का कारण (*Cause of appearance of dohrda in raktagulma*)

दोहदं यत् करोतीति शृणु तत्रापि कारणम् । य एव हि रसः प्रायो धातुर्न वृद्धिहेतवः ॥ ४३॥
तेषामेवाभिलाषः स्वाद्योनिमधमर्तत्ततः । वातपित्ताचितं रक्तं चीयमानं विकारवत् ॥ ४४॥
कक्षप्रलवणादीनां रसानां गुद्धिमावहेत् ॥ ४५॥ (का० सं० खि० ९)

स्त्री (रक्तगुल्म-पीडित) जिस कारण से दौहद करती है उसका भी कारण सुनो । जो रस प्रायः करके धातुओं की वृद्धि का कारण होते हैं, उत्पत्ति-धर्म (रसोत्पत्ति) की समानता के कारण उन्हीं रसों की स्त्री इच्छा करती है । चूँकि यह विकार (रक्तगुल्म) वातपित्ताचित रक्त के एकत्र होने के कारण होता है अतः स्त्री कटु, अम्ल एवं तृण आदि रसों की तीव्र आकांक्षा करती है ।

टीकाकार चक्राणि ने दौहद का कारण मानसिक प्रीति माना है (पृष्ठ ३९४) ।

The specific *rasa* responsible for development of a particular *dohra* (*dosa* and *dhatas*) are desired in case of their requirement in the body. Since *raktagulma* is characterized with accumulation of *rakta* in association of *vāta* and *pitta*, hence the woman craves for articles of *katu* (hot), *amla* (sour) and *lavana* (salty) *rasas*. Cakrapāṇi opines that as a person being suspicious of having taken poison exhibits the symptoms of intoxication even in the absence of poison, similarly due to presence of amenorrhoea the woman feels herself pregnant and has *dohra*.

रक्तगुल्म में स्तन्योत्पत्ति का कारण (*Cause of appearance of milk in breast in raktagulma*)

गर्भिण्यस्मीति तन्म्रीमेसकल्पसंभूतः ॥ ४५॥
प्रसूतो जायते नार्वास्तेन स्तन्यं प्रवर्तते ॥ ४६॥ (का० सं० खि० ९)

स्त्री अपने आपको गर्भिणी समझती है एवं (उस उदरस्थ गर्भ के प्रीति तथा प्रेम के संकल्प के कारण उसे स्त्रियों की उत्पत्ति होती है, जिस कारण स्तन्य का प्रवर्तन होता है ।

टीकाकार चक्राणि ने स्तन्योत्पत्ति का कारण अर्तवरोध से उत्पन्न इस व्याधि का स्वभाव माना है (पृष्ठ ३९४) ।

The woman considers herself pregnant and has affection and determinations for her fetus. Due to this affection milk is formed and excreted through breasts. Cakrapāṇi holds amenorrhoea and nature of disease responsible for milk secretion.

रक्तगुल्म में पाण्डुता का कारण (*Cause of appearance of anaemia in raktagulma* ?)

सर्वा रसवहा नाड्याः समन्तान्नाभिमाश्रिताः ॥ ४६॥
गर्भो विवर्धमानश्च संपीड्यति ताः स्त्रियाः । तद्वच्च रक्तगुल्मोऽपि पीडयन्नुपचीयते ॥ ४७॥
ताभिश्च पीड्यमानाभिर्न सम्यक्वर्तते रसः । आपाण्डुगण्डतादीनि लक्षणानि भवन्त्यतः ॥ ४८॥

(का० सं० खि० ९)

सभी रसवहा नाड़ियाँ नाभि के चारों ओर आश्रित होती हैं । वृद्धि को प्राप्त होता हुआ गर्भ स्त्री में उनका (रसवहा-नाड़ियों का) पीड़न करता है, उसी प्रकार रक्तगुल्म भी पीड़न करता हुआ (रसवहा नाड़ियों का) उपचित होता है । उनके पीड़ित होने के कारण रस का (शरीर में) सम्यक् प्रकार से संवहन नहीं होता, जिसके कारण गण्ड (कपोल) प्रदेश में पाण्डुता आदि लक्षण होते हैं ।

All the *rasavahā nāḍīs* are situated around the umbilicus, which are compressed by

growing fetus. Accumulating and developing *raktagulma* also compresses theses *rasavahā-nāḍīs*. Due to this compression *rasa* does not flow freely in the body resulting into *pāṇḍutā* (whitish yellow colouration) of cheeks etc.

रक्तगुल्म में वृद्धि होने का कारण (*Why raktagulma increases in size ?*)

कथं प्रकथते कालमिति तत्रापि मे शृणु । विबुद्धेरिह सारूप्याद्युगमोऽयमिति निश्चिता ॥ ४९॥
संक्षेतेऽभिषातेभ्यः कुक्कुट्यण्डमिवाङ्गना । तदपायकान् हेतुव कथञ्चन सेवते ॥ ५०॥
श्रमोपवासतीक्ष्णोष्णक्षारादीनि च सर्वशः । स एवं यायमानस्तु यथाकालं प्रकथते ॥ ५१॥
व्यापतिहेतुमासाद्य कालेनाल्पेन वा पुनः । भेदं गच्छत्यस्तत्तिदं जलकुम्भ इव क्षतः ॥ ५२॥

(का० सं० खि० ९)

काल के साथ वह (रक्तगुल्म) किस प्रकार बढ़ता है यह भी मुझसे सुनो । वृद्धि (रक्तगुल्म की रक्त के उपचय से उत्पन्न वृद्धि) में समानता के कारण गर्भ (उदरस्थ गर्भ) निश्चित कर वह स्त्री उसे अभिषात आदि से उसी प्रकार रक्षा करती है जिस प्रकार कि मुर्गी अपने अण्डे की एवं उसे हानि पहुँचाने वाले कारणों यथा श्रम, उपवास एवं तीक्ष्ण, उष्ण (द्रव्यों) तथा क्षारादि का कभी भी प्रयोग नहीं करती । इस प्रकार रक्षा किया जाता हुआ वह (रक्तगुल्म) यथाकाल अर्थात् समय के अनुसार धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है । व्यापति के हेतुओं अर्थात् उपघातक या हानि पहुँचाने वाले कारणों के द्वारा कुछ ही काल के पश्चात् नीचे से फूटे हुए जलकुम्भ के समान इसका भेदन हो जाता है (अर्थात् जिस प्रकार नीचे से फूटे हुए जलकुम्भ का जल अतिशीघ्र ही सम्पूर्ण रूप में निकल जाता है उसी प्रकार रक्तगुल्म भी नीचे अर्थात् योनि-मार्ग से भरित होकर रक्तस्राव के साथ सम्पूर्ण रूप में निकल जाता है) ।

Due to similarity in process of growth (of fetus and *gulma* both) the woman considers herself pregnant and protects her just as a hen protects the egg. She never uses harmful things and avoids totally exercise, fasting, use of pungent or hot articles and *kṣāras*. Thus protected *raktagulma* grows gradually with lapse of time. After some time due to use of contrary or harmful things this *raktagulma* gets loosened, separated and is expelled completely along with blood through vaginal passage in the same way as water drains completely from the pot broken at the bottom.

रक्तगुल्म एवं गर्भ में पार्थक्य करने की आवश्यकता (*The necessity of differentiating raktagulma from pregnancy*)

चिकित्सा करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सभी आन्तार्यों ने गुल्म एवं गर्भ में भेद करने की आवश्यकता का वर्णन किया है परन्तु महर्षि कश्यप ने विस्तृत वर्णन किया है ।

संभूय सह संमन्व्य भिषग्विभः शास्त्रकोविदैः । काले चिकित्सां कुर्वीत यथा वक्ष्याम्यतः परम् ॥ ६२॥
अस्यान्तःस्रावभावोते गर्भो गुल्मश्च रक्तजः । तद्वथावद्विदित्वाऽऽदौ क्रियां कुर्वीद्विषयवतः ॥ ६३॥
यो हि गुल्मे गर्भं इति गर्भं वा गुल्म इत्यपि । क्रियां कुर्वीद्वयशसा एनसा चैव युज्यते ॥ ६४॥

(का० सं० खि० ९)

शास्त्र-पारंगत वैद्यों के साथ एकत्र होकर मन्त्रणा या सलाह करके उचित काल में (रक्तगुल्म की) चिकित्सा करें ता कि मैं आगे वर्णन करूँगा (आगे वर्णित चिकित्सा का दसवें मास में प्रयोग करें), क्योंकि गर्भ एवं रक्तगुल्म में बहुत कम भेद होता है अतः भलीभाँति निश्चित कर चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि जो गर्भ में गुल्म की एवं गुल्म में गर्भ चिकित्सा करता है वह अयश तथा पाप का भागी होता है ।

As there is very little difference between pregnancy and *raktaagulma*, thus the physician should attempt the treatment at the appropriate time only after consulting other erudite and learned physicians, because by prescribing treatment of *raktaagulma* in pregnancy and of pregnancy in *raktaagulma* he would be committing a sin and get defamed.

रक्तगुल्म एवं गर्भ में पार्श्वव्य प्रदर्शित करने वाले लक्षण (The features differentiating *raktaagulma* from pregnancy)

सभी आचार्यों द्वारा वर्णित गुल्म एवं गर्भ के विभेद-कारक लक्षणों का अन्तर्भाव सामान्य लक्षणों के वर्णन के अनन्तरित कर दिया गया है। महर्षि काश्यप ने गुल्म एवं गर्भ के भेदकारक लक्षणों का विस्तृत वर्णन किया है जो निम्न है।

विशेष रक्तगुल्मस्य गर्भस्य च निबोधे मे। अङ्गुप्रत्यङ्गवान् गर्भसंज्ञैव च विवेधेते ॥ ५६ ॥

रक्तगुल्मस्तु वृत्तः स्यान्नोष्ठवच्च विवेधेते। स्थानात् स्थानं व्रजन् गर्भो व्याविद्धं परिवर्तते ॥ ५७ ॥

नाभेरधस्ताद्गुल्मोऽयमव्याविद्धं विवर्तते। आनुपूर्व्येण गर्भश्च अहन्त्यहनि वर्धते ॥ ५८ ॥

विपरीतं हि गुल्मस्तु नन्दं मन्दं विवर्धते। तं तामवस्थां गर्भस्तु मासि मासि प्रपद्यते ॥ ५९ ॥

गर्भेणी नानिमित्तं च च्यवते दहतेऽपीवा। गुल्मिनी ह्यनिमित्तं तु च्यवते दहतेऽपि वा ॥ ६० ॥

अस्मिन् विशेषेऽपि सति संदेहो जायते महान्। नानागर्भविकारणां सङ्कागद्विषये मतः ॥ ६१ ॥

(का० सं० खि० ९)

अब तु मुझसे गर्भ एवं रक्तगुल्म का भेद सुन। अङ्गों प्रत्यङ्गों से युक्त गर्भ उन्हीं (अङ्गों प्रत्यङ्गों) से चेष्टा करता है जब कि रक्तगुल्म गोलकार लोष्ट या पथर सदृश चेष्टा करता है या स्पन्दन करता है। गर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान में बन्धन रहित होकर गति करता है, रक्तगुल्म नाभि के नीचे बन्धन युक्त सदृश किञ्चित् लुङ्कता रहता है। गर्भ प्रतिदिन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है इसके विपरीत गुल्म धीरे धीरे बढ़ता है। गर्भ प्रत्येक मास में उस उस अवस्था को (प्रथम में कालत, द्वितीय में घन, तृतीय में अङ्गीकृति) प्राप्त होता है (जो गुल्म में नहीं होता)। गर्भेणी बिना किसी कारण के (ज्यारि के निदान के) च्चर या दाह से पीड़ित नहीं होती परन्तु रक्तगुल्म पीड़ित स्त्री बिना किसी कारण के ही च्चर एवं दाह से पीड़ित होती है। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के होते हुए भी गर्भ सबन्धी नाना विकारों के मिल जाने से निदान में महान संशय हो जाता है।

लक्षणान्तराति वर्णित विषय के आधार पर रक्तगुल्म एवं गर्भ के विभेदक लक्षण तालिका ९ में दिए जा रहे हैं।

रक्तगुल्म	गर्भ
तालिका ९	
१. केवल पिण्डरूप में, लोष्ट सदृश एवं नाभि के नीचे बंधन-युक्त सदृश किञ्चित् स्पन्दन करता है, या कभी स्पन्दन नहीं भी करता।	अङ्गों प्रत्यङ्गों से, स्वतंत्र रूप से एवं अपेक्षाकृत तीव्र स्पन्दन करता है।
२. त्रिकाल में शूल के साथ स्पन्दन करता है।	अपने सामान्य काल में, बिना शूल के ही स्पन्दन करता है।
३. गुल्म की ही वृद्धि होती है। कुक्षि की नहीं।	गर्भ के साथ साथ कुक्षि की भी वृद्धि होती है।
४. उदर में ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो जाती हैं एवं स्तनान्तर तथा नाभि-प्रदेश में नीले धब्बे दिखाई देते हैं।	ऐसा कुछ नहीं होता।
क्रमशः	

१. चि० सं० चि० ३/२४ व चक्रपाणि टीका व चि० ५/१९; सु० सं० उ० ४२/१४, १५ व डल्हण टीका; अ० सं० चि० ११/४५; अ० ह० चि० ११/५४ व ५५; भा० प्र० चि० ३२/१८; मा० चि० २८/१६, यो० २० गु० चि० (पृष्ठ ३९३ से ३९६)

- गुल्म धीरे धीरे बढ़ता है एवं वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता। गर्भ प्रतिदिन क्रमशः बढ़कर मासानुमासिक वृद्धि को प्राप्त होता है।
- गुल्म में बिना किसी कारण के ही स्त्री को काम, अतिसार, निद्रा, च्चर एवं दाहदि अनेकों लक्षण होते हैं अर्थात् ये रक्तगुल्म के लक्षण हैं। गर्भेणी को विशिष्ट कारण होने पर ही काम, अतिसार, च्चर या दाहदि होते हैं अर्थात् ये गर्भ के लक्षण नहीं हैं।
- गर्भशय में शूल तथा योनि से दुर्गन्धित स्राव होते हैं। इस प्रकार के कोई लक्षण नहीं होते।
- गुल्म का भेदन होने पर केवल रक्त का स्राव होता है, गर्भपात या प्रसव होने पर रक्त के साथ गर्भ भी बाहर गर्भ या गर्भाङ्ग दुष्टिगोचर नहीं होते। निकलता है।

The points differentiating *raktaagulma* from pregnancy have been given with clinical features by the authors, however Kaśyapa has described these separately i.e. fetus quivers with body-parts in free manner, while *raktaagulma* quivers like a solid mass in restricted manner; fetus develops in specific month wise order while *raktaagulma* develops slowly, the pregnant woman does not suffer from fever etc. without specific cause, while fever etc. are the features of *raktaagulma*.

Raktaagulma considerably stimulates pregnancy. Following are differentiating points.

Raktaagulma

Pregnancy

- Gulma* quivers just like a solid mass or multer, below the umbilicus in restricted way; sometimes it does not quiver. Quickening is delayed and is associated with pain. Quickening starts earlier, and is without pain.
- Only *gulma* increases in size not the *kukṣi* (uterus). Corresponding to the development of fetus *kukṣi* also develops.
- Glands appear over the abdomen and blue spots inbetween breasts and around umbilicus. No such sign in pregnancy.
- Growth of *gulma* is very slow and does not follow a definite sequence. Fetus grows comparatively earlier and follows a definite pattern of development according to gestational months.
- Cough, diarrhoea, sleepiness, fever and burning sensation etc. are the clinical features of *gulma* itself. Cough, diarrhoea, fever and burning sensation etc. appear during pregnancy due to their specific etiology. These are not the clinical features of pregnancy.
- Gulma* is associated with pain in uterus and foul smelling vaginal discharges. Such features are not found in pregnancy.
- During expulsion along with blood only *gulma* is expelled, fetal parts are absent. During expulsion (abortion or delivery) fetus is delivered along with blood.

रक्तगुल्म के उपद्रव (Complications of raktagulma)

ज्वरालिचिक्तासकासशोषकार्श्यातिव्यथाः । शोफश्चोपद्रवा गुल्मे तीक्ष्णकिंसेत् स्वधेयैः ॥७४॥
(का० सं० चि० ९)

ज्वर, अरुचि, ज्वाम, कास, शोष, कार्श, अरति (रक्तानि), व्यथा (शूल या कष्ट) तथा शोफ आदि गुल्म के उपद्रव होते हैं जिनकी चिकित्सकों को उन उपद्रवों के लिए प्रयुक्त औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए ।

अन्य आचार्यों ने रक्तगुल्म के किन्हीं विशिष्ट उपद्रवों का (पेटन के समय अत्यधिक रक्तस्राव को छोड़कर) वर्णन नहीं किया ।

Fever, anorexia, dyspnoea, cough, consumption, emaciation, uneasiness, pain and edema are the complications which should be treated by the physician. Besides excessive bleeding may occur during the process of its expulsion.

रक्तगुल्म की असाध्यता के लक्षण (Clinical features denoting bad prognosis)

यद्यपि आचार्यों ने विशेष रूप से रक्तगुल्म के किन्हीं असाध्यता के लक्षणों का वर्णन नहीं किया परन्तु सभी प्रकार के गुल्मों के लिए वर्णित असाध्यता के लक्षणों को असाध्य रक्तगुल्म के भी लक्षण समझने चाहिए ।

महर्षि चरक ने लिखा है कि क्रमशः सींचित हुआ गुल्म जो अत्यधिक स्थान में व्याप्त हो गया हो, जिसकी मूल दृढ़ हो गई हो, शिप्राओं से आनद्ध (सिराजाल-व्याप्त) एवं कछुए के समान उन्नत हो तथा दौर्बल्य, अरुचि, हृन्नास, कास, वमन, अरति, ज्वर, पुष्पा, तन्द्रा तथा प्रतिरूपाय से युक्त हो वह गुल्म असाध्य होता है । जिस ज्वर, श्वास, वमन तथा अतिसार युक्त गुल्म रोगी के हृदय, नाभि, हस्त एवं पाद में शोफ हो जाय, उसको वह शोफ मार डालता है अर्थात् इन लक्षणों से आक्रान्त होने पर वह रोगी मर जाता है^१ ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि श्वाम, शूल, पिपासा, अन्नद्वेष, ग्रन्थिमूला (गुल्म का न दिखना देना) तथा दुर्बलता आदि जिस गुल्म के रोगी को हो जाय वह निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है^२ ।

वाग्भट-द्वय ने भी गुल्म की असाध्यता के लक्षणों में लिखा है कि विस्तृत परिधि वाला, घना (टोस), कूर्म के समान उभार वाला अर्थात् मध्य में अधिक उन्नत तथा किनारे की ओर क्रमशः कम उन्नत, सिराओं से अच्छादित तथा ज्वर, खाँद, हिष्मा, आध्मान, रज्जा (स्थानिक एवं सार्वदहिक), कास, पीनस, हृन्नास, श्वास, अतिसार तथा शोफ से युक्त गुल्म असाध्य होता है^३ ।

आचार्य भावमिश्र, माधव तथा योगान्ताकर ने महर्षि चरक एवं सुश्रुत दोनों के ही वर्णनों का उल्लेख किया है^४ ।

१. माह्वितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः । कृतमूलः सिरानद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ १६१॥
दौर्बल्याल्लिचिक्तासकासवमनारतिज्वरैः । पुष्पातन्द्राप्रतिरूपायैर्युक्तै न स सिध्यति ॥ १७०॥
गृहीत्वा सञ्चक्ष्वासं वम्यतीसारपीडितम् । ह्रन्नाभिरुत्प्रादेषु शोफः कर्षति गुल्मनाम् ॥ १७१॥ (च० सं० चि० ५)
२. श्वासशूलपिपासाविद्वेषग्रन्थिमूलाः । भवति दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मृत्युमेधताः ॥ (सु० सं० सू० ३३/२१)
३. गुल्मः पुष्पपरिणतो घनः कूर्म इवोन्नतः । सिरानद्धो ज्वरच्छदीहिष्माऽध्मानरज्जाच्चितः ॥
कासपीनसहृन्नासश्वासातीसार शोफवान् ॥ (अ० सं० शा० ११/२०, २१ एवं अ० ह० शा० ५/८८, ८९)
४. सञ्चितः इवोन्नतः । दौर्बल्या... छर्षतीत्यर्थः । सिध्यति । गृहीत्वा... छर्षतीसार... । शोषः... । (चरक संहिता सन्तुष्ट ही) श्वासः शूलं पिपासाऽज्जाविद्वेषे ग्रन्थिमूला । जायते दुर्बलत्वं गुल्मिनो मरणाय वै ।
(भा० प्र० चि० ३२/१९ से २२, भा० नि० २८/१७ से २०-इवोन्नतः के स्थान पर इवोन्नतः; सन्तुष्ट ही)

श्री २० गुल्म नि०, भा० प्र० सन्तुष्ट परत्तु कृतमूलः के स्थान में कृतमूलः)

Though bad prognostic sign/symptoms specially for raktagulma have not been described, however, features of incurability mentioned for gulma in general can be considered for raktagulma also. These are—

Gradually accumulating gulma involving larger area, solid, having deep seated roots, covered with net of vessels, having protuberance like tortoise, and associated with weakness, anorexia, nausea, cough, vomiting, uneasiness, fever, thirst, drowsiness, hiccup, flatulence, pain, colic, dyspnoea, diarrhoea and edema is incurable. The patient of gulma already having fever, dyspnoea, vomiting and diarrhoea if develops edema over cardiac and umbilical region and also on extremities, then the patient dies.

रक्तगुल्म-चिकित्सा (Treatment of raktagulma)

रक्तगुल्म का चिकित्सोपयोगी काल (Appropriate period for the treatment of raktagulma)

महर्षि चरक एवं कारक ने दश मास व्यतीत हो जाने पर तथा सुश्रुत एवं वाग्भट ने प्रसव-काल व्यतीत हो जाने पर ही चिकित्सा का विधान बताया है^१ ।

टीकाकार चक्रपाणि ने दश मास के पश्चात् चिकित्सा को सुख चिकित्सा अर्थात् आसानी से की जाने वाली चिकित्सा बताया है एवं लिखा है कि इसके पूर्व चिकित्सा करने पर रक्त की अतिवृत्ति एवं गर्भाशय को आघात आदि उपद्रव हो सकते हैं । यह कहा गया है कि दश मास के पश्चात् गर्भ के सदृश गुल्म का भी अवधारण अर्थात् स्वयमेव पात हो जाता है, अतः चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी गर्भ वर्ध-गण तक भी स्थिर रहता है एवं गुल्म का पात दश मास के पूर्व भी हो जाता है^२ (अर्थात् दश मास के पश्चात् चिकित्सा सुख-साध्यता की दृष्टि से ही वर्णित है) ।

टीकाकार डल्हण ने प्रसवकाल के पश्चात् चिकित्सा करने का कारण पिण्डीभूत रक्तगुल्म की सुखसाध्यता मानते हुए उद्धरण दिया है कि ज्वर में गुल्म-दोषता, प्रमेह में गुल्म-दूषता एवं रक्तगुल्म में पुण्डला सुखसाध्यता के लक्षण हैं, एवं स्पष्ट किया है कि 'दश मास के पश्चात् चिकित्सा' एवं 'प्रसव-काल के पश्चात् चिकित्सा' इस वर्णन में कोई मत-वैभिन्य नहीं है । यदि रक्तगुल्म भली भाँति उपचित (एक स्थान में एकत्रित) हो जाय तो प्रसव-काल के पूर्व भी चिकित्सा कर सकते हैं^३ ।

१. (अ)मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ (च० सं० चि० ५/१९)
(आ) तं गर्भकालातिगमे चिकित्स्यमसुभवं गुल्ममुशाति तज्ज्ञाः ॥ (सु० सं० उ० ४२/१५)
- (इ) रक्तगुल्मे पुनरीतप्रसवकालाया... । (अ० सं० चि० १६/७७)
- (ई) गत प्रसवकालादे नार्थे गुल्मेऽसम्भवे ॥ (अ० ह० चि० १४/१९९)
- (उ) केचिद्व्यति गुल्मस्य मासाददशमात् परम् ॥ ५३॥ (का० सं० चि० ९)
२. मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य इति प्रभावाहशममासातिक्रमे एवास्य सुखा चिकित्सा भवति, अर्थात् चिकित्सायां तु शोणितानि-सुतिर्भाशयोपघातादि स्यात् । यद्युच्यते-गर्भसमनातिवृत्तेनास्य दशममासादूर्ध्वं सैविराज्जन्मावधारणं भवति, तेनार्वाचिकित्साऽत्र नोक्तिः, तत्र, दशममासातिक्रमेऽपि गर्भावस्थानदर्शनात् । उक्तं हि "पुष्टौ यदा वर्धयतीति स्यात्".... । तथा समीपिडितत्वं गर्भलक्षणानिर्दृष्टलक्षणमुक्तं; तेन दशममासादवर्गापि शोणितगुल्मावधारणं भवत्येव,.... । (च० सं० चि० ५/१९ की चक्र० टीका)
३. गर्भकालातिगमे प्रसूतिकालोत्तिक्रान्ते, प्रसूतिकालादनन्तरं पिण्डीभूते रक्तगुल्मे स्नेहादिगोपसकृतेहायाः सुखसाध्यत्वम् । उक्तं च "ज्वरे गुल्मदुर्बलत्वं प्रमेहे गुल्मदूषता । रक्तगुल्मे पुण्डलं सुखसाध्यम् लक्षणम्" इति । केचिदेवं व्याख्यायन्ति- 'मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः' इति वक्तव्ये 'तं गर्भकालातिगमे चिकित्स्यम्' इति । यत् कृतं तद्वक्तव्ये सत्यमुपचिते प्रसूतिकालादवर्गापि चिकित्सा कारणीयेति बोधयति ॥ (सु० सं० उ० ४२/१५ की डल्ह० टीका)

टीकाकार इन्द्र ने दश मास या प्रसवकाल के पश्चात् चिकित्सा-वर्णन केवल गर्भ की श्रान्ति दूर करने के ही कारण माना है^१।

महर्षि काश्यप ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि फल के सदृश ही अपने काल के परिणाम से दशमास के पश्चात् गुल्म का भी परिणक हो जाता है (अर्थात् जिस प्रकार अपना समय आने पर फल पक जाता है उसी भाँति रक्तगुल्म भी दशमास में परिपक्व हो जाता है)। इस समय (परिपक्वता-काल में) व्याधि अत्यधिक दुरुपक्रम (कठिनाता से चिकित्सा-योग्य) नहीं रहती, अतः विद्वान लोग इस समय चिकित्सा करने की इच्छा करते हैं। गर्भ के सदृश ही गुल्म भी अग्रास काल में पाया होता है, पक्व हो जाने पर यह व्याधि आसानी से भेदित हो जाती है^२ (अर्थात् गर्भ को यदि पूर्ण-काल के पूर्व प्रसवित करने का प्रयत्न किया जाय तो कठिनाई होगी पर प्रसव-काल प्राप्त हो जाने पर तनिक प्रयत्न से ही प्रसव प्रारम्भ हो जाता है, उसी प्रकार रक्तगुल्म भी परिपक्व हो जाने पर तनिक से प्रयत्न से ही भेदित हो जाता है)।

आचार्य भावमिश्र, माधव एवं योगरत्नाकर ने भी दशमास के पश्चात् ही चिकित्सा का विधान बताया है^३ टीका में स्पष्टीकरण चक्रपाणि की ही भाँति दिया है कि दश मास के पश्चात् चिकित्सा गर्भ-शोक के कारण न होकर सुखसाध्यता के कारण से वर्णित है, क्योंकि दश मास के पूर्व रक्तगुल्म की लीनता के कारण गर्भारण्य-आघात आदि होने की सम्भावना अधिक होती है^४।

Treatment of *raktagulma* should be done after tenth month of its onset or after the period of normal labour has elapsed. Cakrapāṇi has clarified that tenth month period has been said as it is easily curable after this period. If treatment is attempted before tenth month, excessive bleeding and injury to the uterus etc. complications are likely to occur. The idea that after tenth month *gulma* will also automatically get expelled just like fetus is not correct, because sometimes fetus stays in uterus for years together and *gulma* is expelled before tenth month. Dalhana opines that presence of identical *dosas* and *dāsyas* in fever and *prameha* respectively and chronicity in *raktagulma* are the features for easy curability, however, if proper localization of *raktagulma* occurs it can be treated even before tenth month. Indu says that tenth month period is advised for differentiating it from the fetus. Kāśyapa has written that as the fruit gets ripened in its appropriate time, similarly *gulma* attains maturity in ten months and then it is easily curable and gets expelled easily, however before this period the treatment is a bit difficult.

१.। तदा हि निष्प्रान्तिर्गुल्मे भवति ॥ (अ० सं० चि० १६/४० की इन्द्र टीका)

२. केचिद्विचरन्ति गुल्मस्य मासादशमासं परम् । परिणकं फलस्यैव स्वकालपरिणामतः ॥ ५३ ॥

तस्मिंश्च काले स व्याधिः स्यात्प्रातिदुरुपक्रमः । ततोपक्रमीनचर्चति तस्य कर्तुमती बुधाः ॥ ५४ ॥

अग्रप्रासकालो याव्यः स्याद्वर्षद्युतिकोविदैः । नापक्वो भिद्यते व्याधिरिति मत्वा यथायमम् ॥ ५५ ॥ (क्रा० सं० चि० ९)

३. मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः । ... (भा० प्र० चि० ३२/१८; भा० नि० २८/१६ एवं यो० २० गु०)

४. (अ) इति न संशय व्यवच्छेदार्थं किन्तु तदा सुखेन चिकित्साऽर्हं ...। (भा० प्र० चि० ३२/१८, की टी०)

(आ) व्यतीतेऽतिक्रान्ते । गर्भसमानतिद्वत्त्वेन संशयः गर्भो वा, रक्तगुल्मो वा इति ...। तत्र ...। तस्मादेवं

दशमासाव्यतिक्रमे चिकित्साविधानस्य प्रयोजनं, किन्तु व्याधिमहिम्ना तावदेव कालेन तस्य चिकित्साया सुखोच्छेदन-

मिति.....। यद्यवर्षाकभेदेन क्रियते तथा गर्भस्य व्याधिर्निषिद्धा, तद्वीर्यलादरक्तस्य;.....।

(भा० नि० २८/१६ की मधु० व्याख्या)

Identical views have been expressed in the books i. e. Bhāvaprakāśa. Mādhavanīdāna and Yogaratnakara.

गर्भ से भ्रम होने पर रक्तगुल्म की चिकित्सा (Principle of treatment in doubtful case)

अतस्तु संशये जाने कुर्वीत साधारणीः क्रियाः । नोपक्रमेदविदितं रोगं काश्चिच्चिकित्सकः ॥ ६५ ॥

(क्रा० सं० चि० ९)

(गर्भ है या रक्तगुल्म इस) संशय के उत्तर होने पर साधारण क्रिया करनी चाहिये (गर्भ एवं रक्तगुल्म दोनों में ही लाभदायक, पर भेदन चिकित्सा नहीं) क्योंकि बिना रोग का ज्ञान किसे चिकित्सक को कभी भी उपाय (चिकित्सा) नहीं करना चाहिए ।

If the physician is unable to differentiate between pregnancy and *raktagulma* he should prescribe general treatment beneficial in both the conditions (general tonics etc. not abortifacient). Specific treatment should not be attempted without correct diagnosis.

प्रसव-काल या उसके पूर्व रक्तलाव होने पर चिकित्सा (Treatment of bleeding before or during the time of labour)

अथ काले त्वसंपूर्णं संह्रिये चापि दर्शने । हेतुना केनचिद्रक्तं सवेतं चाशु वारयेत् ॥ ६६ ॥

पूर्णे प्रसवकाले तु न रक्तं प्रतिवारयेत् तत्रानुवासनं दद्याद् द्रवं निम्बं च भोजनम् ॥ ६७ ॥

विधिनाऽनेन गर्भंश्चेत् सुखेन प्रसविष्यति । अथवा रक्तगुल्मः स्यात् सोऽप्यकृत्स्नेन भेत्स्यते ॥ ६८ ॥

एतस्मात् कारणाद्वक्तं प्रवृत्तं न निवारयेत् ॥ (क्रा० सं० चि० ९)

अपूर्ण-काल (प्रसव-काल के पूर्व) में यदि किसी कारण से रक्तलाव होने लगे एवं संह्रियता (गर्भ एवं रक्तगुल्म की स्थिति में) हो तो उस (रक्तलाव) को शीघ्र ही दूर करना चाहिए (अर्थात् रक्त सन्तप्त कर देना चाहिए) एवं प्रसव-काल पूर्ण हो जाने पर (यदि रक्तलाव हो तो) रक्तलाव का निवारण (सम्पन्न) नहीं करना चाहिए, उस काल में अनुवासनवर्त्ति तथा द्रव एवं निम्ब भोजन देना चाहिए । इस विधि से यदि गर्भ है तो वह सुखपूर्वक प्रसवित हो जायगा एवं यदि रक्तगुल्म है तो उसका भी पूर्ण रूप से भेदन हो जायगा, इसी कारण से प्रवृत्त हुए रक्त को नहीं रोकना चाहिए ।

If bleeding (per vaginum) occurs before the time of labour i. e. tenth month, and diagnosis of pregnancy or *raktagulma* is doubtful, then measures to control bleeding should be employed. However, if bleeding occurs after attainment of normal labour period, it should not be controlled and *anuvāsanabasti* (nutritive enema) along with liquid and unctuous diet should be prescribed. By this procedure the woman if pregnant will deliver easily, if having *raktagulma* it will also be expelled completely, so bleeding at this stage should not be controlled.

यशकाल में चिकित्सा-सिद्धान्त (Treatment in its appropriate period)

(अ) सामान्य गुल्म की चिकित्सा के सिद्धान्त (Principles of treatment of *gulma* in general)

आचार्यों ने लिखा है कि वायु की विकृति के बिना कोई भी गुल्म नहीं होता^१, अतः सर्वप्रथम वायु की ही शान्ति

१. (अ) सर्वेष्वपि खल्वेतरेषु गुल्मेषु न काश्चिद्विद्वद्वै सम्भवति गुल्मः । (च० सं० नि० ३/१६)

(आ) गुल्मो हि वातादृतो न सम्भवति । (अ० सं० चि० १६/२)

के उपाय विधिवत् करने चाहिए। वायु के शान्त हो जाने पर दूसरे बड़े हुए दोष अल्प प्रयत्न से भी शान्त हो जाते हैं। सामान्य रूप से गुल्म के लिए निम्नलिखित चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए।

(१) एक दोष गुल्म में दोषानुसार चिकित्सा एवं जो अविरुद्ध चिकित्सा समझे उसे उपद्रवों को गुल्मा तथा लघुता का विचार कर प्रयुक्त करें। गुरु उपद्रवों को चिकित्सा शीघ्र ही करे तथा लघु की चिकित्सा बाद में करें, चिकित्सा शीघ्रता से करते हुए यदि गुल्म के विशिष्ट भेदों का ज्ञान (वातपित्तादि भेदों का) न हो सके तो उसमें वायुनाशक चिकित्सा करनी चाहिए।

(२) वायु शमन के लिए सर्वप्रथम स्नेहन एवं स्वेदन करना चाहिए^{३,३}। स्वेदन कुम्भी, पिण्ड या इष्टिका (ईंट या पथर से) के द्वारा करना चाहिए (कुम्भी में वातनाशक द्रव्यों का क्वाथ पर कर, पिण्ड ग्नेद के लिए वात-नाशक द्रव्यों का पिण्ड बनाकर तथा प्रसृत स्वेद के पश्चात् वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ से अवसिंचन) एवं शालचण (वेशवार) आदि का सुखोष्ण उपनाह, स्वेदन एवं अनुलोमन कुशल वैद्य को करना चाहिए।

(३) स्नेह (स्निग्ध पदार्थ यथा घृतादि) से युक्त मृदु विरेचन दे^{३,३}।

(४) स्नेह से युक्त बस्ति दे^{३,३}।

(५) स्नेह से युक्त अम्ब, लवण एवं मधुर रसों का प्रयोग युक्तिपूर्वक करें^{३,३}।

(६) लेंधान, दीपन, स्निग्ध, उष्ण, वातानुलोमक तथा बृंहण अन्न के सेवन से सभी गुल्मों में लाभ होता है।^४

(७) जगाल जीवों का सुखोष्ण मांसस स्नेह एवं सैन्धव मिलाकर त्रिकटु से युक्त कर पीने को देना चाहिए।

(८) गुल्म-स्थान या बाहु की मध्य की शिरा से रक्तमोक्षण करना चाहिए।

(९) इसमें निरुह बस्ति देने की चाहिए क्योंकि यह निरुह के योग्य व्याधि है।

Any type of *gūlma* can not develop without vitiation of *vāta*, hence initially measures to suppress *vāta* should be adopted. Once *vāta* is controlled other *dosas* subside easily.

Following is the general method of treatment for any type of *gūlma*.

i) In the *gūlma* developing due to vitiation of one *dosā*, the treatment to suppress that particular *dosā* should be given, besides other beneficial treatment considering

१. (अ) मारते ह्यपशाने स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो निवर्तुं गुल्मोच्छिन्ति।

गुल्मनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवत्वावर्तितव्या। मारते ह्यवर्जितेऽन्यमुदीर्णं दोषमन्यथापि कर्म निहन्त्या॥

(च० सं० वि० ३/१६, १७)

(आ) मारते हि विविधेऽल्पेनापि यत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो गुल्मेषु नियन्तुम्। (अ० सं० वि० १६/२)

(इ) गुल्मिनामनिलः.....। मारते तु विविधेनिहन्त्या। (यो० १० गुल्म० वि०, चरक सङ्ग्रह)

२. एकदोषेने तु यथास्वामासम् प्रणयेत्। यवाभ्यदप्यविरुद्धं मन्यते तदप्यवचारोऽपि भुज्य गुल्मावयवपुष्टवर्णां, गुल्मुद्र-वास्त्वामाण्डकिरसेज्ज्वन्यमिमतान्। त्वत्प्राणसु विशेषणपुनरुत्पन्नानो गुल्मेऽन्यथाधिके कर्मणि वातचिकित्सितं प्रणयेत्।

स्नेहस्वेदौ वातहर्तौ स्नेहोपसंहितं च मृदुविचित्रं वस्तीह, अम्लतलवणमधुराक्ष रसान् युक्त्याऽवचारयेत्॥ (च० सं० वि० ३/१६)

३. तन्मात्रो सर्वेषां प्रथमं स्नेहस्वेदौ वातहर्तौ। स्नेहोपसंहितं मृदुविचित्रं तद्विधांश्च बहुशो वतान्तरतलवणमधुराक्ष रसान् युक्त्यावचारयेत्॥ (अ० सं० वि० १६/२)

४. लङ्घनं दीपनं स्निग्धमधुर्णं वातानुलोमम्। बृंहणं च भवेदन्नं तद्विधं सर्वगुल्मनाम्॥

सुखोष्ण जाह्नलरसाः सुस्निग्धा व्यक्तसैन्धवाः। कटुत्रिकसामयुक्ता हिलाः पानेषु गुल्मिनाम्॥

कुम्भीपिण्डेऽपि कासस्वेदनाकारोऽकुशलो पिषकः। उपनाहाश्च कर्तव्याः सुखोष्णाः शालचणपदयः॥

गुल्मस्थाने रक्तमोक्षो बाहुमये शिराव्ययः। स्वेदानुलोमनं चैव प्रशस्तं सर्वं गुल्मिनाम्॥ (यो० १० गुल्म वि०)

५. का० सं० सि० ७/१४।

severity and mildness of complications should be done. Serious complications should be treated first and mild complications afterwards. If differential diagnosis regarding specific types i. e. *vātaja*, *pittaaja* etc. is not possible then treatment to suppress the *vāta* should be given.

ii) To suppress *vāta*, oleation, sudation and carminatives should be used. Sudation should be done with *kumbhī* (filling the ewer with decoction made of drugs capable of suppressing *vāta*), *piṇḍa* (a solid made of *vāta* suppressing drugs), *isṭikā* or *prastara* (heated brick or stone followed by irrigation with decoction of *vāta* suppressing drugs). Poultice of luke warm *śālvāna* (*vēdāwāra* a paste made of meat or cooked oleo with other drugs) should also be applied.

iii) Mild laxatives mixed with fat (*ghṛta*) should be given.

iv) Enema with fat (oil) should be given.

v) Sour, salty and sweet substances mixed with fat should be given.

vi) Fasting, use of *dīpāna* (appetizing), *snigdha* (unctuous), *uṣṇa* (hot) and *vātānulomaka* (carminative) things and also *vṛṇhāna* diet is beneficial.

vii) Luke warm meat-soup of wild animals mixed with fat, salt and *trikāya* should be given.

viii) Venesection of the vein either situated near the *gūlma* or in the middle of arm (cubital vein) should be done.

x) *Nirāha basti* (evacuative enema) should be prescribed.

(आ) रक्तगुल्म के विशिष्ट चिकित्सा सिद्धान्त (Principles of treatment specific for raktagūlma)

(१) रक्तगुल्म में प्रसवकाल व्यतीत हो जाने के बाद स्नेहन एवं स्वेदन करा कर स्निग्ध विरेचन देना चाहिए^{३,४,६,७}।

(२) रक्तगुल्म में पित्तगुल्म^{३,७} सङ्ग (काकोल्यादि घृत से स्नेहन देकर विरेचन एवं मधुर द्रव्यों से निर्मित निरुह बस्ति^३) चिकित्सा एवं रक्त का भेदन करना चाहिए।

(३) स्नेहन देकर पाक के निवारणार्थ बाहु की शिरा का वेधन तथा शेष दोष-निर्हरणार्थ संशमन चिकित्सा करनी चाहिए^५।

(४) यह व्यधन एवं विरेचन योग्य व्याधि है अर्थात् इसमें वेधन एवं विरेचन का प्रयोग करना चाहिए।

१. सौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे। स्निग्धस्निग्धशरीरयै दद्यात् स्नेहविरेचनम्॥ (च० सं० वि० ५/१७२)

२. पित्तगुल्मादित स्निग्ध काकोल्यादिघृतेन तु। विरिक्तं मधुरैर्योगैर्निरुहैः समुपाचरेत्॥

पित्तद्रक्तगुल्मिन्या नार्थाः कार्यः क्षियविधिः। विशेषमपूरं चारस्याः शृणु रक्तविधेदन्म्॥ (शु० सं० उ० ४२/१९, २०)

३. रक्तगुल्मे पुनर्तातिप्रसवकालाया योषितः स्नेहस्वेदपूर्वकं स्नेहविरेचनं कर्तव्यं॥ (अ० सं० वि० १६/४७)

४. गतप्रसवकालायै नार्थं गुल्मोऽस्यसम्भवे। स्निग्धस्निग्धशरीरयै दद्यात् स्नेहविरेचनम्॥ (अ० सं० वि० १४/१९९)

५. रक्तगुल्मे प्रथमतो युक्त्या स्नेहोपनादनम्॥ ६९॥

शस्तं बाहुशिरायाश्च वेधनं पाकवारणम्। तथा संशमनीयं च दोषशेषावकर्षणम्॥ ७०॥ (का० सं० वि० ९)

६. स्निग्धस्निग्ध शरीरस्य योज्यं स्नेहविरेचनम्॥ (पा० प्र० वि० ३२/४६)

७. पित्तद्रक्तगुल्मिन्या नार्थाः कार्यो यथाविधि। प्रस्निग्धस्निग्धकोष्ठया योज्यं स्नेहविरेचनम्॥ (यो० १० गु० वि०)

८. दकोदराणि संपाका गुल्मा ये ये च रक्तजाः। व्यध्याः.....। (च० सं० वि० २५/५०)

९. शो० सं० सि० ९

- i) After the time of labour has elapsed, oleation, sudation followed by unctuous laxatives should be prescribed.
- ii) It should be treated just like *pitajagulma* (oleation with *kāṅkolyādi ghṛa* followed by laxation and *nirūha basti* made with *madhura* drugs) and measures to expell the *rakta* (abortifacients) should be adopted.
- iii) To avoid supuration, oleation followed by venesection of cubital vein should be done. To remove left over *dosas samānana* (suppressive) treatment should be given.
- iv) The disease is fit for purgation and puncturing or perforation or else purgatives should be used and it should be punctured.

(इ) रक्तगुल्म विकृतिसार्थ आयुर्वेदार्थ प्रयुक्त औषधियाँ (Oral medicines for raktagulma)

- (१) पलाशक्षार एक पात्र (दो आडक क्षारोदक) में दो दो पात्र (चार चार आडक) तैल (तिल का) एवं घृत (गोघृत) या केवल घृत पकाकर ^{३,१०} (जब स्नेह शेष रह जाय तब) मात्रानुसार (राणा के बलाबलानुसार) देना गुल्म को शिथिल करता है।
- (२) रक्तपित नाशक क्षार (नीलोत्पलक्षार-चक्रपाणि) को मधु एवं घृत के साथ चटना चाहिए ^{१,४}।
- (३) रक्तगुल्म पीड़ित स्त्री को लघुन, तीक्ष्ण मदिरा और मत्स्य का प्रयोग करना चाहिए ^{१,४}।
- (४) गुल्म के भेदन के लिए तीक्ष्ण एवं उष्ण औषधियों का प्रयोग करना चाहिए ^{३,३८}।
- (५) स्त्रियों के रक्तगुल्म में अनर्तव्य हो जाने पर तिल के क्वाथ में घृत, गुड़, व्योष तथा भाङ्गी का चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए ^{३,१०}।
- (६) भाङ्गी, कृष्ण करंज-त्वक्, ग्रन्थिका तथा अमरदारु का चूर्ण तिल के क्वाथ में मिलाकर पीने से गुल्म को वेदना शान्त होती है ^{४,८}।
- (७) विकृतिसा-कर्म-विशेषज्ञ को वेदना से युक्त रक्तगुल्म पीड़ित स्त्री को कल्याणक, पंचगव्य, षट्पल एवं तिकक घृत का प्रयोग दोषानुसार करना चाहिए।
- (८) रक्तगुल्म को शिथिल करने के लिए बिल्व एवं श्योनाक से साधित जांगल पशु-पक्षियों का मांसस देना चाहिए।

१. पलाशक्षारपात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः । गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मानां प्रयोजयेत् ॥ १७३ ॥
रक्तपित्तहं क्षारं लेहयेन्मधुसर्पिषा । लघुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यंश्चास्यै प्रदापयेत् ॥ १७४ ॥
(क्षारपात्रे इति क्षारोदकस्याडकद्वयम्-चक्रपाणि) (च० सं० चि० ५ एवं चक्र० टीका)
२. पलाशक्षारतोत्रेन सिद्धं सर्पिः प्रयोजयेत् ।.....उर्ज्वा भेदयेत्॥ (सु० सं० उ० ४२/३०, २१)
३. पलाशक्षारोदकसिद्धं च यमकम् । गुल्मभेदनाय तीक्ष्णोष्णं च विधिम् । (यमकम् घृततैल-इन्दु)
(अ० सं० चि० १६/४७ एवं इन्दु टीका)
४. तिलस्त्रयो घृताड्योषभाङ्गीरजोन्मिताः । पानं रक्तमये गुल्मे नष्टे पुष्ये च योषितः ॥ १२० ॥
भाङ्गीकृष्णकरञ्जाल्यगुग्गुलिकाऽमरदारुणम् । चूर्णं तिलानां क्वाथेन पीतं गुल्मसन्नापहम् ॥ १२१ ॥
पलाशक्षारपात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः । गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मानां प्रयोजयेत् ॥ १२२ ॥
रक्तपित्तहं क्षारं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ १२५ ॥
लघुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यंश्चास्यै प्रयोजयेत् ॥ १२६ ॥ (अ० ह० चि० १४)

क्रमशः

- (९) गुल्म में गति उत्पन्न करने के लिए एवं विवेचनार्थ कुलत्थ के यूष अथवा लावा (के मांसस) से संस्कृत विवृत अथवा त्रिफला पीने को देना चाहिए।
- (१०) उपक्रम के पश्चात् (गुल्म के शिथिलीकरण के पश्चात्) गुल्म के शोधन एवं पातन करने के लिए हरीतकी, वचा, हिंगु, सैन्धव, अम्लवेतस, यवानी तथा यवशूक (यवक्षार) के चूर्ण को उष्ण जल के साथ पीने को दे।
- (११) हरीतकी, यवक्षार तथा सैन्धवजल (लवण) इन तीनों का घृत के साथ युक्तिपूर्वक पान रक्तगुल्म का भेदन करता है।
- (१२) पत्र, एला, पिप्पली एवं शुण्ठी के चूर्ण को विड्मलवण मिलाकर अथवा केवल नागर एवं शुक्ति के चूर्ण को गोमूत्र के साथ मिलाकर पीने को देना चाहिए।
- (१३) सूक्ष्मैला, कुंचिका, चव्य, पिप्पली तथा चित्रक के कल्क को बल्वन के यूष अथवा मण्डोदक के साथ पीने को देना चाहिए।
- (१४) अपरा-पातन के लिए प्रयुक्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए।
- (१५) पत्र आदि (उत्पल एवं अन्य पत्र जाति के द्रव्य यथा उत्पलादिगण के द्रव्य) को मूल सहित लेकर जलाकर उसकी भस्म बनाकर तथा उसके क्वाथ को गाढ़ा करके, उसको शुण्ठी, पिप्पली, कुष्ठ, चव्य, चित्रक एवं दारु के चूर्ण के साथ पकाए। जब वह दारु (कलछी) में प्रलेपित होने लायक गाढ़ा हो जाय तो उसका प्रयोग करने से शोधन (गुल्म का) होता है।
- (१६) शिलाजीत तथा अभयारिष्ट कल्क के सेवन से भी रक्तगुल्म में लाभ होता है।
- (१७) लोष, अर्जुन, खदिर, मागधिका तथा समंगा के क्वाथ में अम्लवेतस तथा मधु एवं शर्करा मिलाकर पीने से रक्तगुल्म, हृक्लेद तथा रक्त के दोषों का शीघ्र ही नाश होता है।
- (१८) रक्तगुल्म तथा यकृत एवं क्षतज (विकारों या गुल्म) के विनाश के लिए घृत तथा सैन्धवजल (लवण) युक्त क्षीर पीने को देना चाहिए।
- (१९) शलाह्व, त्रिवर्जित्व-त्वक्, दारु, भागी तथा कणा के कल्क को तिल-क्वाथ के साथ रक्तगुल्म को नाश करने के लिए पीने को देना चाहिए।
- (२०) धात्री के स्वरस का मरिच (के चूर्ण) के साथ पान करना रक्तगुल्म विनाशक है।

क्रमशः

५. कल्याणकं पञ्चगव्यं षट्पलं तिकमेव वा । सरलां पायथेनार्तं दोषवित् कर्मकोविदः ॥ ७१ ॥
बिल्वरथोनाकमिदं सार्धैर्जलैर्जले रसैः । शैथिल्यकरणार्थं च रक्तगुल्मस्य भोजयेत् ॥ ७५ ॥
यूषेण वा कुलत्थानां लावसंस्कारिकेण वा । चालानार्थं विरेकं च त्रिवर्जित्वक्या पिबेत् ॥ ७६ ॥
उपक्रमेणैतद्दृष्टव्यैः शोधनपातनैः । हरीतकी वचा हिङ्गु सैन्धवं साल्ववेतसम् ॥ ८० ॥
यवानी यावशूकं च चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत् । हरीतकीयवक्षारसैर्वर्जलमिति त्रयम् ॥ ८१ ॥
घृतयुक्तं पिबेद्युक्त्या रक्तगुल्मस्य भेदनम् । पत्रैलापिप्पलीशुण्ठीचूर्णं वा विडसंयुतम् ॥ ८२ ॥
नागरं शुक्तिचूर्णं वा पिबेद्दोषप्रसृज्युतम् । सूक्ष्मैलाकुष्ठिकाचव्यपिप्पलीविकसस्य वा ॥ ८३ ॥
कल्कं बल्वनयूषाद्यैः पिबेन्मण्डोदकेन वा । अपरापातनोद्देशेऽपि भेदयेत् ॥ ८४ ॥
पञ्चादीनि साल्गानि दाध्या तद्व्रम सहरेत् । गाढयित्वा च तत्क्वाथं चूर्णैस्तीक्ष्णैश्च ॥ ८५ ॥
शुण्ठीपिप्पलीकुष्ठैश्च चव्यविकरदासभिः । दार्विप्रलेपितं सिद्धमभ्यसेन शुद्ध्यति ॥ ८८ ॥
शिलाजम्बवभाण्डि कल्पोनाप्यस्य मुच्यते ॥ ८९ ॥ (का० सं० चि० ९)
६. त्रेधाऽर्जुनखदिरमागधिकासमङ्गक्वाथोऽप्लवतसमधुघृतसंयुतः ।
गुल्मं सक्तमपि चाथ निहतं चाधु, हृक्लेदं च विनिहति च कुक्षारकम् ॥ ७२ ॥
क्षीरपानं प्रदातव्यं घृतसैवर्जलचितम् । रक्तगुल्मविनाशाय यकृद्द्विदलजेऽपि वा ॥ ७३ ॥ (हृ० सं० तृ० स्थाने २६)

क्रमशः

(२१) गुग्गु (गुग्गु) अथवा गुग्गु एवं तोचनिका के चूर्ण को शर्करा तथा मधु मिलाकर रक्तगुल्म पीड़ित स्त्री के दोषों को दूर करने (मल रेषन) के लिए देना चाहिए^{७८} ।

(२२) क्षार (यवक्षार) को मूषण तथा घृत मिलाकर रक्तगुल्म पीड़ित स्त्री को पीने को देना चाहिए ।

(२३) तिल-मूल, शिणु, ब्रह्मदण्डी-मूल, मधुसूदी तथा त्रिकटु के चूर्ण का सेवन रजोरोध तथा वातगुल्म में रक्तियों को शोष ही लाभ करता है ।

(२४) दन्ती (मूल), हिणु, यवक्षार, अलखु के बीज, कणा तथा गुड़ को लेकर (समान भाग लेकर) स्त्रीक्षीर के साथ (मदन कर्क) गुटिका बनकर एक कर्ष को मात्रा में सेवन रक्तगुल्म का नाशक एवं रक्षित-स्नात-कारक होता है ।

(२५) अर्क-पुष्प को तैल में पकाकर सेवन करने से रक्षित का स्वाद होता है ।

i) *Palāśa-kṣāradaka* (the liquid from which the *kṣāra* is prepared) in the dose of one *pātra* (2 *āḍhaka*) mixed with two *pātra* (4 *āḍhaka*) each of *tila* oil and cow *ghṛta* or only *ghṛta* should be cooked with standard procedure. Use of this in appropriate dosage loosens *gulma*.

ii) The *kṣāra* beneficial for *raktapiṭta* such as *kṣāra* prepared from *niḥtipala* mixed with honey and *ghṛta* should be given.

iii) Garlic, strong wine and fish should be prescribed to the woman suffering from *raktagulma*.

iv) Pungent and hot medicines should be prescribed for separating the *gulma*.

v) Decoction of *tila* mixed with *ghṛta*, jaggery, powders of *vyoṣa* and *bhāṅṛgi* should be prescribed for amenorrhoea developing in *raktagulma*.

vi) Use of decoction of *tila* mixed with powders of *bhāṅṛgi*, *kṛṣṇā*, stem-bark of *karavīṭa*, *grāhikā* and *amaradāru* relieves pain associated with *gulma*.

क्रमशः

७. शालाह्वीचरित्वत्सदरभार्गिकणोद्धवः ॥ ४६ ॥

कल्कः पीतो जयेद्गुल्मं तिलक्वाथेन रक्तञ्च । तिलक्वाथो गुडव्योषधुतभार्गियुतो भवेत् ॥ ४७ ॥

योनिरकमवे गुल्मे नष्टपुष्पेषु योषिताम् । पीतो धानोरसोयुक्तो मरिचैश्चासृजन्मुतु ॥ ४८ ॥

गुडरोचनिकाचूर्णं शर्कराभाक्षिकाचिन्तम् । विदलीनाशु गुलिन्या मलसङ्घट्टक्रम्य च ॥ ४९ ॥

विशेषमन्त्रश्चाशु शृणु रक्तप्रभेदनम् । पलशशातोयेन सर्पिः सिद्धं पिबेच्च सा ॥ ५० ॥

सक्षारं मूषणं सर्पिः प्रविशेदसृजन्मिनी ॥ ५१ ॥ (भा० प्र० चि० ३२)

८. शालाह्वी.....तिलक्वाथेन रक्तञ्च (भा० प्र० सदृश) ॥

तिलक्वाथो गुडव्योषधुतभार्गिरजोचिन्तः । पानं रक्तमवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषितः ॥

तिलमूलं च शिणुं च ब्रह्मदण्डीमूलकम् । मधुसूदीविकटुकैर्दुर्लभं चूर्णमुपसेवेत् ॥

पुष्परोधे वातगुल्मे स्त्रीणां सद्यः सुखान्वहम् ॥

भार्ग्यक्रियाकारश्चैतन्मृद्विक्वाथमदररक्तञ्च । चूर्णं तिलानां क्वाथेन रक्तगुल्मरुजान्वहम् ॥

दन्ती हिङ्गुयवक्षारालवबीजकणागुडाः ।

स्तुहीक्षीरेण गुटिका-सर्वेषां कर्षमात्रिका । पक्षिला रक्तगुल्मयो रक्षितस्नातकारिणी ॥

पुष्पं तैलेर्धर्कं पुष्पं रक्षितस्नातकारि च । पलशशातोयेन सर्पिः सिद्धं पिबेदधुः ॥

गुडरोचनिका चूर्णं शर्कराभाक्षिकाचिन्तम् । विदलीनासृजन्मिनी मलरोचनञ्च च ॥ उष्णैर्वा भेदेयेत् ...॥ (योग २० गु० चि०)

vii) To relieve the pain *kalyāṇaka*, *pañcagavya*, *śarpāla* or *tilaka ghṛta* should be prescribed on the basis of specific *doṣa*.

viii) Meal soup of wild animals or birds medicated with decoction of *bilva* and *śyonāka* should be given for loosening the *raktagulma*.

ix) To mobilize the *gulma* and for purgation *trivṛt* or *triphalā* mixed with soup of *kulathā* or meat of quail should be given.

x) Once the *gulma* is mobilized, then for cleansing and expelling it, powders of *haritākā*, *vacā*, *hingū*, rock salt, *amlavetasa*, *yavāni* and *yavakṣāra* should be prescribed with hot water.

xi) Methodical use of *haritākā*, *yavakṣāra*, and *sauva-cala* salt with *ghṛta* expels the *gulma*.

xii) Either powdered *paira*, *elā*, *pippalī* and *śunthī* mixed with *viḍ* salt or powders of *nāgara* with *bhasma* of *śukti* should be prescribed with cow's urine.

xiii) Pestled small variety of *elā*, *kuñcika*, *cavya*, *pippalī* and *citraka* either mixed with juice of *balvaja* or water prepared with scum of boiled rice should be given.

xiv) Medicines prescribed for expelling the placenta can be used.

xv) *Padma* etc. plants along with their roots should be burnt, and decoction of this ash should be prepared. When the decoction gets thickened, powders of *śunthī*, *pippalī*, *kuṣṭha*, *cavya*, *citraka* and *dāru* should be mixed in it and boiled till the substance is so thick that it gets adhered in the ladle. Use of this electuary expels the *gulma*.

xvi) Use of *śilājīta* and *abhyāviṣṭa* as a *kalpa* is also beneficial in *raktagulma*.

xvii) Decoction of *lodhra*, *arjuna*, *khadira*, *māgadhiḥkā*, *samanigū* mixed with *amlavetasa*, honey and sugar cures immediately *raktagulma*, *hṛtkleda* (nausea) and *rakta-doṣas* (blood disorders).

xviii) Milk mixed with *ghṛta* and *sauvarcala* salt should be prescribed in *raktagulma*, *yakṛta* (liver) and *kṣāṭaja* (traumatic) disorders.

xix) Pestled *śatāhwā*, stem bark of *citrabilva*, *dāru*, *bhāṅṛgi* and *kaṇā* mixed with decoction of *tila* should be prescribed.

xx) Use of juice of *dhātūrī* mixed with powder of *marica* cures *raktagulma*.

xxi) To eradicate *doṣas* of the woman suffering from *raktagulma* powders of *gunḍā* or *mūṇḍī* and *rocānikā* mixed with honey and sugar should be prescribed.

xxii) *Yavakṣāra* mixed with powder of *tryūṣaṇa* and *ghṛta* should be prescribed.

xxiii) Use of powders of root of *tila*, stem bark of *śigeru*, root of *brahmadanḍī*, *madhyasṛī* and *trikāṭa* is beneficial to the woman suffering from amenorrhoea and *vātagulma*.

xxiv) Powdered root of *danu*, *hingū*, *yavakṣāra*, seeds of *alḍhu* and *pippalī* mixed with jaggery should be triturated with latex of *śunthī* and tablets should be made. Use of these tablets in the dose of one *karṣa* cures *raktagulma* and initiates bleeding per vaginam.

xxv) Use of flowers of *arka* fried with oil initiates bleeding.

(ई) रक्तगुल्म-चिकित्साार्थं योनि-विशोधक वर्ति या पिचु (*Vaginal tampons or pessaries for the treatment of raktagulma*)

यदि आप्मन्तर प्रयुक्त औषधियों से गुल्म का भेदन न हो तो योनि-विशोधक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए^{१,३,३३}।

(१) क्षार (यवक्षार) अथवा सुधाक्षार (सेहुण्ड के दुग्ध) के साथ पलत (मांस या तिल का कलक) को योनि में धारण करने को देना चाहिए^{१,३,३३}।

(२) (यवक्षार तथा सेहुण्ड-दुग्ध) दोनों से भावित कटुक मत्स्य (शेफरी शुष्क मत्स्य) को योनि में धारण करना चाहिए^{१,३,३३}।

(३) वराह तथा मत्स्य के पित से भावित वस्त्र को योनि में धारण करने को दे^{१,३,३३}।

(४) अशोषाहार (विरिचक) तथा ऊर्ध्वभाग हर (वामक) द्रव्यों (के क्वाथ) से भावित वस्त्र^३ अथवा इन्हीं के क्वाथ एवं मधु मिश्रित^१ वस्त्र (वस्त्र को क्वाथ एवं मधु में भिगाकर तथा पिचु बनाकर) योनि में धारण करे।

(५) किण्व, गुड़ एवं क्षार (यवक्षार) को मिलाकर (वर्ति बनाकर) योनि-विशोधन के लिए देना चाहिए^{१,३,३३}।

If *gulma* does not get loosened and separated with oral medicines, then local medicines should be used. Following drugs, tampons or pessaries should be prescribed to be placed in vagina / cervix :—

- Palala* (pestled meat or *tila*) mixed with either *yawakṣāra* or latex of *snuhi*.
- Katuka matsya* (special kind of fish) treated (dipped repeatedly and dried) with *yawakṣāra* and latex of *snuhi*.
- Cloth soaked with bile of hog and/or fish.
- Cloth soaked with decoction of purgative and emetic drugs with or without honey.
- A pessary made with *kinva* (seeds or drugs used for fermentation), jagger and *yawakṣāra*.

(उ) रक्तगुल्म-चिकित्साार्थं बस्ति (*Use of basti for the treatment of raktagulma*)

(१) दुग्ध, गोमूत्र एवं क्षार (यवक्षार) को मिलाकर दशमूल क्वाथ को बस्ति (उत्तरबस्ति) देना चाहिए^{१,३,३३}।

१. प्रभिद्येत न यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनम्। क्षारेण युक्तं पलतं सुधाक्षारिणं वा पुनः ॥ १७४॥

आप्यां वा भावितान् दद्याद्योनीं कटुकमत्स्यकान्। वराहमत्स्यपिताप्यां लककान् वा सुभावितान् ॥ १७५॥

अशोहैश्वर्यहर्भावितां वा समक्षिकैः। किण्वं वा सगुडक्षारं दद्याद्योनिविशोधनम् ॥ १७६॥ (च० सं० वि० ५)

२. एवमभिधाने योनीं योनिविशोधनार्थं क्षारेण युक्तं पलतम्। ताप्यां वा भावितान् कटुकमत्स्योस्तस्मिन् भावितान् वा वराहपित्तभावितान् वा नक्तकान् ख्याधोषाग्निकद्रव्यभावितान् वा। सगुडक्षारं किण्वं वा (अ० सं० वि० १६/४८)

३. न प्रभिद्येत यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनम्। क्षारेण युक्तं पलतं सुधाक्षारिणं वा ततः ॥ १७७॥

ताप्यां वा भावितान् दद्याद्योनीं कटुकमत्स्यकान्। वराहमत्स्यपिताप्यां नक्तकान् वा सुभावितान् ॥ १७८॥

किण्वं वा सगुडक्षारं दद्याद्योनीं विमुह्यते ॥ १७५॥ (अ० ह० वि० १४)

नोट-रक्तगुल्म-चिकित्साार्थं बस्ति के सन्दर्भ पृष्ठ ४९३ में देखें।

(२) पिप्पल्यादि घृत को उत्तरबस्ति देनी चाहिए^१।

(३) तीक्ष्ण द्रव्यों के द्वारा आस्थापन तत्पश्चात् युक्तिपूर्वक अनुवासन बस्ति दे^१।

(४) वायु की शान्ति के लिए फलतैल के द्वारा अनुवासन बस्ति देकर शूल तथा आटोप निवारणार्थ एक या दो बार आस्थापन बस्ति देवे^१।

(५) मधु तथा तैल समान भाग लेकर इन दोनों के समान उष्ण जल लें, उसमें दो कर्ष शतगुण्य तथा आधा कर्ष सैवय डालकर इससे अथवा दशमूल क्वाथ से आस्थापन बस्ति दे^१।

i) *Utarabasti* (vaginal / uterine irrigation) with decoction of *dasāmāla* mixed with milk, cow's urine and *yawakṣāra* should be given.

ii) *Utarabasti* with *pippalyādi ghṛta* should be given.

iii) *Āsthāpāna basti* (cleansing enema) prepared with pungent drugs should be given, followed by methodical use of *anuvasānabasti* (nutritive enema).

iv) *Anuvasāna basti* with *phalatalaia* should be given to suppress vāyu, this should follow use of *āsthāpāna basti* once or twice for relief of pain and tympanites.

v) Honey and oil in equal quantity should be mixed with similar amount of hot water. Now two *karsa śatapuspa* and ¹/₂ *karsa* salt should also be mixed. Either with this preparation or with decoction of *dasāmāla* the *āsthāpāna basti* should be given.

आस्थापन बस्ति के पश्चात् पथ्य (*Dietetic regimen after basti treatment*)

आस्थापन या अनुवासन बस्ति के पश्चात् क्षीर, यूष, रस (मांसरस) आदि को संस्कृत करके बलानुसार पथ्य में दे^१।

After giving *āsthāpāna* or *anuvasāna basti* properly medicated milk, soup of pulses, vegetables and meat should be prescribed according to her strength.

(ऊ) रक्तगुल्म का भेदन (*Bhedana or separation of raktagulma*)

यद्यपि सामान्य चिकित्सा वर्णन करते समय सभी आचार्यों ने गुल्म के भेदन करने के लिए विभिन्न औषधियों का आप्मन्तर एवं बाह्य प्रयोग वर्णित किया है जो पूर्व पृष्ठों में है। परन्तु महर्षि चरक एवं अष्टांगहृदयकार ने सभी चिकित्सा

१. बस्ति च क्षीरपूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम्। (च० सं० वि० ५/१७८)

२. दद्यादुत्तरबस्तिं च पिप्पल्यादिघृतेन तु ॥ (सु० सं० उ० ४२/२१)

३. बस्ति च सक्षारक्षीरपूत्रं दाशमूलिकमुत्तरबस्तिं च योजयेत् ॥ (अ० सं० वि० १६/४८)

४. (अ० ह० वि० १४/१२६-अक्षरशः चरक सङ्ग्रह)

५. तीक्ष्णैरास्थापयेदेनं युक्तिकक्षानुवासयेत् ॥ ७२॥

वायोपशमार्थं च फलतैलानुवासिताम्। आस्थापयेत् सकृद्विं शूलटोपनिवृत्तये ॥ ७०॥

तुल्यं मधु च तैलं च ताप्यामुष्णोदकं समम्। द्वौ कर्षौ शतगुण्याः कर्षार्धं सैववस्त्र च ॥ ७८॥

एतेनस्थापयेत्तर्तं दशमूलोदकेन वा ॥ ७९॥ (का० सं० वि० ९)

६. पथ्यानि भोजयेन्नेव क्षीरयूषसादिभिः ॥ ७२॥

बलं चाप्याययेत्तस्या रसैः क्षीरेक्ष संस्कृतैः ॥ ७९॥ (का० सं० वि० ९)

का वर्णन करने के उपरान्त लिखा है कि यदि रक्षिर अदृश्यमान रहे अर्थात् चिकित्सा से रक्त-प्रवृत्ति न प्रारम्भ हो तो गुल्म का प्रभेदन हितकारी होता है^१। यह सम्भव है कि यहाँ गुल्म-भेदन से आचार्यों का तात्पर्य शल्य-क्रिया अर्थात् शस्त्र-कर्म द्वारा गुल्म-भेदन हो।

If *gulma* does not get loosened or separated and bleeding per vaginam does not start with earlier described treatment then its *bhedana* (loosening or separation) is advisable.

In preceding pages recipes for oral administration or vaginal insertion to induce bleeding and expel the *gulma* have already been mentioned. It appears that probably here the authors have indicated some surgical interference to remove the *gulma*.

(ए) गुल्म-विकित्सा से रक्त की प्रवृत्ति होने पर विश्रान्त (Treatment of bleeding during expulsion of rakta-gulma)

रक्षिर की प्रवृत्ति होने पर उसकी उपेक्षा करे अर्थात् उसे रोकने का प्रयत्न न करे^२, तथा मांसस एवं ओदन भोजन के लिए दें^३, एवं शरीर का अभ्यास घृत अथवा तैल द्वारा करे तथा पीने के लिए तरुणी सुता दें^४।

When the bleeding starts, it should not be taken care of, in other words no attempt should be made to check the bleeding. Rice with meal soup should be given in diet, body should be massaged with oil or *ghrita* and fresh wine should be given for drinking.

(ऐ) गुल्म-भेदन के पश्चात् रक्त की अति प्रवृत्ति होने पर विकित्सा (Treatment of excessive bleeding per vaginam after expulsion of gulma)

(१) रक्तपित्त-नाशक^{५,६,७,८} या अमृतादरव^९ चिकित्सा करें अर्थात् रक्त का अवरोध करना चाहिए^१।

(२) तित्तिर एवं मूयों का मांसस, सुता एवं मण्ड का प्रयोग तथा अम्लसर्पि (अम्ल द्रव्यों से साधित घृत) का पान करना चाहिए^१।

(३) घृत एवं तैल से अवसेचन करना चाहिए^१।

(४) भोजन के पश्चात् जीवनीय गण से साधित घृत का पान अथवा इसी घृत से बस्ति (उत्तर) देना चाहिए^१।

(५) तिक द्रव्यों से साधित घृत से अनुवासन देना चाहिए^१।

उपर्युक्त चिकित्सा के ही साथ महर्षि चरक ने वातरागात् अर्थात् वातरोग से पीड़ित होने पर (सम्भवतः रक्तनिक्षुप्ति होने के कारण वात-प्रकृति हो जाती हो) वात-नाशक क्रिया का विधान दिया है^१। अष्टांगहृदयकार ने इस वात-नाशक क्रिया के वर्णन के बाद आनाह आदि उपद्रवों में उदावर्तनाशक तथा कफनाशक चिकित्सा करने का निर्देश दिया है^१। यह सम्भवतः उपद्रवों की चिकित्सा है।

१. (अ) अदृश्यमाने रक्षिरे दद्याद्गुल्मभेदनम् । (च० सं० चि० ५/१७८)

(आ) अवर्तमाने रक्षिरे हितं गुल्मभेदनम् । (अ० ह० चि० १४/१२७)

२. प्रवर्तमाने रक्षिरे दद्यान्मांससौदनम् । घृततैलेन चाप्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुताम् ॥ (च० सं० चि० ५/१७९)

३. प्रवृत्तं तु रक्तं रसौदनशिन्वा उपेक्षेत ॥ (अ० सं० चि० १६/४९)

४. यमकोप्यकदेश्याः प्रवृत्ते समुपेक्षणम् ॥ १२७॥

रसौदनस्तथाऽऽहारः पानं च तरुणीं सुता ॥ १२८॥ (अ० ह० चि० १४)

क्रमशः

i) Bleeding should be controlled with the drugs prescribed for *raktapitta* or *asyrgdara*.
ii) Soup of meal of partridge or cock, wine, scum of boiled rice and *ghrita* medicated with sour drugs should be given.

iii) Irrigation with *ghrita* or oil should be done.

iv) *Ghrita* medicated with *jivantiya* group of drugs should be given after meals, or *uttarabasi* with this very *ghrita* should be given.

v) *Anuvāsana basti* with *ghrita* treated with bitter drugs should be given.

If the woman suffers from *vājāya disorders* (due to excessive blood loss the *vāya* gets agitated) measures to suppress *vāya* should be applied. For treatment of *ānāha* (flatulence) etc. treatment prescribed for *udāvāra* and *kapha*-suppressing measures should be used.

(ओ) गुल्म के अवरोध रह जाने पर रक्तातिप्रवृत्ति की चिकित्सा (Treatment of excessive bleeding per vaginam after incomplete expulsion of gulma)

गुल्म-दोष के निकल जाने पर या उसके अवरोध रह जाने पर (गुल्म का कुछ भाग गर्भाशय में ही रह जाय तो) यदि अतिप्रवृत्त होता हुआ रक्त रक्तानि (कण्ड) उत्पन्न करे तो आस्थपानोक्त विधि से पुनः उसकी चिकित्सा करें तथा अनुबन्ध (अन्य दोषों के अनुबन्ध होने के) के पथ से शनैः शनैः शोधन करना चाहिए^१।

Excessive bleeding after complete or incomplete expulsion of *gulma* if gives trouble to the woman then *āsthāpāna* etc. treatment prescribed earlier should be restarted. Very gradual *sōdhana* (evacuation) of *gulma* should be done, lest other *dosas* get provoked and involved.

क्रमशः

५. रक्षिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरीः क्रियाः । कार्पा वातरागाद्याः सर्वा वातहरीः पुनः ॥ १८०॥

घृततैलावसेकांश्च तित्तिरीश्वरणाशुधान् । सुतां समण्डां पूर्वा च पानमम्लस्य सर्पिषः ॥ १८१॥

प्रयोजयेदुत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा । अतिप्रवृत्ते रक्षिरे सति केनानुवासनम् ॥ १८२॥

(अम्लस्यसर्पिषः अम्लद्रव्यसाधितस्य घृतस्य । उत्तरं भोजनोत्तरकालं पानं, किंवोत्तरवर्तिनः-चक्रभाषिण)

(च० सं० चि० ५, एवं चक्र० टीका)

६.भिन्ने विधिरास्यदो हितः.... (विधिरास्यदो इति रक्तपित्तोक्तो विधिः कुत एतत् ? अमृतदे

रक्तपित्तविधिरित्येतत्....अधोनागरक्तपित्तचिकित्सामत्र कार्याभिहित-डह्लण) (सु० सं० ३० ४२/२१ एवं डह्लण टीका)

७. अतिप्रवृत्तं तु रक्तं रक्तपित्तोपक्रमेण साधयेत् ॥ (अ० सं० चि० १६/४९)

८. रक्षिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरीः क्रियाः ॥ १८०॥

कार्पा वातरागाद्याः सर्वा वातहरीः पुनः । आनाहवातबुलवर्तकालसाब्ध्यौ यथाशयम् ॥ १८१॥ (अ० ह० चि० १४)

९.भिन्ने विधिरास्यदो हितः । अतिप्रवृत्तमस्तं तु भिन्ने गुल्मे निवारयेत् ॥ (यो० २० गुल्म० चि०)

१०. अतिप्रवृत्तं रक्षिरे रक्तानि जनयते यदि । विनिहिते गुल्मदोषे सावरोधेऽपि वा पिषङ्क ॥ ८५॥

पुनरास्थपानोक्तेन तत्र कुर्याद्विभिन्नाम् । अनुबन्धपयाच्चेव शनैस्तदुपशोधयेत् ॥ ८६॥ (का० सं० चि० ९)

आचार्यों ने रत्नगोत्र-विक्रित्वा के साथ किसी विशेष पथ्य का विधान वर्णित नहीं किया, अतः गुल्म की सामान्य विक्रित्वा एवं सामान्य पथ्य यहाँ भी निर्दिष्ट समझना चाहिए। महर्षि कारयप एवं हरीत ने कुछ विशिष्ट अपथ्यों का निर्देश किया है जो निम्नीकृत है।

रक्ष, विदाहि एवं गुरु अन्न-पान का सेवन, व्यायाम, मैथुन तथा चिन्ता का गुल्मोण से पीड़ित स्त्री को परित्याग करना चाहिए^१ ।

रक्तगुलम में पावन, हिंगुपान, कटियालान (कमर हिलाना), स्वेदन, मर्दन, चंद्रकण्ठा, उत्तरवान (उखलाना) हितकारी तथा हिङ्ग-यक्त पत्र एवं जंगल मोसस रक्तगुलम एवं क्षतज गुल्म में हितकर नहीं है ।

Use of *rukṣa* (dry or free from fat), *vidāhī* (producing burning sensation) and *guru* (heavy) diet, exercise, coitus and worry are contraindicated. Use of *pācana* (digestive) drugs and *hiṇṇa*, movements of hips (excessive), sudation, massage, walking and jumping etc. are harmful. Hot and *vidāhī* things or edibles containing *hiṇṇa* and meat soup of wild animals are also not beneficial in the cases of *raktagulma* and *kṣatāja gulma*.

गुलम का शाब्दिक अर्थ झाड़ी होता है। सभी आचार्यों ने इसकी उत्पत्ति में वायु को ही कारण माना है एवं यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृतिपित वायु स्वयं ही या अन्य दोषों को उनके अपने अपने या अन्य स्थानों पर एकत्र करके गुलम की उत्पत्ति करती है। सामान्य गुलम का वर्णन करते समय महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि हृदय एवं बलि के मध्य में, ग्रथ के आकार की, संचारी अथवा अचल, चय तथा अपचयवान्, वृत्ताकार अकृति गुलम कहलाती है। वायु की प्रधानता के कारण, व्याधि का मूल अव्यक्त या गूढ़ तथा गुप्तमत्त या विशाल होने के कारण इसे गुलम कहते हैं। टीकाकार डल्हन ने 'चयोपचयवान्' को व्याख्या करते हुए इसे वायु की विचित्र क्रिया के कारण कभी अपचित एवं कभी पचित होने वाला माना है एवं पाठान्तर का वर्णन करते हुए 'स्थिरोपचयवान्' अर्थात् स्थिर होकर वृद्धि करने वाला लिखा है। गुलम शब्द का शाब्दिक अर्थ एकत्रोत्पन्न एवं विशालता दिया है। माधवनिदान की मधुकोषव्याख्याकार ने 'चयोपचयवान्' से कभी उपचित एवं कभी अपचित होना तथा पाठोदर का उद्धरण 'चदनोपचयवान्' देते हुए चदन अर्थात् एकर उपचयवान अर्थात् बढ़ने वाला लिखा है^१।

१. अत्रापानानि रूक्षाणाम् विदारहीनि गुरुणि च । व्यायामं मैथुनं चित्तानि गुरितमनो तु विवर्धयेत् ॥ ७३ ॥ (कां. सं० चि० ९)
२. साकगुल्मे न तु पाचनं तु न हिङ्गुपाचनं कटिचालनं च ।
न चैव सेस्तेद न मर्दनश्च नाक्रमेण (यु० पा० न चक्रमं) गोत्सलवर्गं हितं च ॥ ७१ ॥
न च हिङ्गुतु पथ्यं न चोष्णं न विदारिह च । रक्तमे क्षतमे गुल्मे मांसाणि जङ्गलानि च ॥ ७२ ॥
(हा० सं० तृ० स्थाने २६)
३. हृदरुह्योत्तरे ग्रथिः सञ्चारी यदि वाऽचलः । चयापचयवान् वृत्तः स गुल्म इति कीर्तितः ॥
गुप्तिनातिलमूलत्वाद्, गूढमूत्रोदघादपि । गुल्मवत् वा विशालत्वाद्, गुल्म इयमभेदीयः ॥ (सु० सं० उ० ४२/४, ६)
४. । चयापचयवान् कदाचिदपचित्राः कदाचिदपचित्रा इति, विचित्रक्रियात्वाद्, वायोः । । 'चयापचयवान्' इत्यत्र
'स्थितोपचयवान्' इति केचित् पठन्ति, स्थिर उपाचये वृद्धिर्यस्य स । गुल्मवत् मनुष्यादिंसंहतिवत् । विशालत्वाद्
विस्तीर्णत्वात् ॥ (सु० सं० उ० ४२/४ तथा ६ को डहल० टीका)
५. चयापचयवानिति कदाचिदुपचयीयो कदाचिदपचयीयोः 'चयापचयवान्' इति पाठान्तरे दोषस्य चयनोपचयवानिति
वृद्धिर्भातिन्यर्थः ॥ (मा० नि० २८/२ को मैथु० व्याख्या)

292

गुलम-व्याधि की सानान्य सम्प्राप्ति का वर्णन करते समय महर्षि चरक ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सम्प्राप्ति रक्तगुलम की नहीं है ।

गुलम एवं विद्रधि में भैद का वर्णन करते हुए महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि गुलम स्वदोष में ही आश्रिता रहते हैं गुलम एवं पक्वते हैं अथवा नर्ही भी पक्वते । इसलिए देह में पक्वते है

उपनिषद् वर्णन के आधार पर रक्तजुगल गर्भाशय में हों (क्योंकि रक्त का स्थान गर्भाशय है^१) एवं महर्षि चरक, वाग्भट, काश्यप एवं चक्रपाणि ने गर्भाशय का स्पष्ट उल्लेख किया है^२) केवल रक्त के एकत्र होने से उत्पन्न, घृताकार या गुल्माकार, विस्तृत, चय अर्थात् वृद्धि को प्राप्त होकर अपचयवान अर्थात् घटने वाली, मध्यम आयु की सामान्य ऋतुचक्र वाली स्त्रियों को ही होने वाली व्याधि है। इसके निदान एवं सम्प्राप्ति स्वतन्त्र है, सामान्य गुल्मों से सम्बन्धित नहीं है।

लक्षणां के वर्णन में महर्षि सुश्रुत को छोड़कर सभी आचार्यों ने स्पन्दन एवं गुल्मवृद्धि का वर्णन किया है। सुश्रुत-टीकाकार 'डहण' ने स्पन्दन की उपास्थिति को स्वीकार किया है। यदि 'नस्पन्दतो गोदरोति वृद्धि' के नव प्रत्यय का नकारात्मक अर्थ न काके 'ईषत्' किया जाय तो ईषत् स्पन्दन एवं उदर वृद्धि अर्थां हो जायेगा एवं अन्य आचार्यों से मत-वैभिन्न नहीं रह जायेगा।

रक्तगुलम व्याधि क्या है ? इसका निर्णय करने के लिए सभी संहिताओं में वर्णित विषय के समष्टि स्वरूप का अवलोकन आवश्यक है ।

यह व्याधि रक्त के गर्भाशयान्तर एकत्र होने से, प्रजनन-शक्ति युक्त, सामान्य आर्तव-स्राव वात्सी स्त्रियों में ही होती है। प्रकृति वायु शुक्र-युक्त या शुक्र-गहित आर्तव को प्रतिमास गर्भाशयान्तर एकत्र करता है। कारण स्वरूप नवप्रसूता, ब्रह्मसूती या योनिनीरोगी द्वारा वात-प्रकोपक आहारों के सेवन से वायु का प्रकोप, योनि-स्नाम्न एवं योनि-लेखन औषधियों का प्रयोग तथा अन्य योनिरोगों की उपस्थिति वर्णित है।

लक्ष्णों को मुख्यतया निम्न भागों में बाँट सकते हैं:-

१. सामान्य :- ज्वर, कास, वेदना, अंगमर्द, निद्रा, आलस्य, स्तम्भित, पादशोफ, मूर्छा, नेत्रलालिनी, पाण्डू, कुशला, उदर में ग्रन्थियाँ आदि ।
२. पाचन संस्थान सम्बन्धी :- शूल, अरोचक, अविपाक, वमन, हृक्षस, अतिसारादि ।
३. गर्भ सम्बन्धी :- रतनपीरवर्तन, कुक्षि-वृद्धि, पिण्डवृत्त-विरकाल में शूल के साथ स्पन्दन, दौहद, रोमराजी ।
४. प्रजनन संस्थान सम्बन्धी :- अनातर्व, गर्भाशय-शूल, तोद, भेद, योनि-विस्मरण एवं योनि से दुर्गन्धित स्राव, स्पन्दन, रक्त का एकत्रीकरण, स्वयमेव भेदित हो जाने की प्रवृत्ति एवं भेदन होने पर रक्तस्राव ही मुख्य लक्षण ।
- उपर्युक्त सभी लक्षणों में अनातर्व तथा गर्भ-सदृश लक्षण का अत्यधिक महत्व है ।
-
१. चण सं० वि० ५/६ की चक्रपाणि टीका (पृष्ठ ३८९)
३. (अ) स्वदोषादिपिण्डानश्च सर्वो भवति गुल्मः । तस्माच्चिरेण नैव पाकमेति । (अ० सं० नि० ११/४६)
- (आ) स्वदोषसंश्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सः ॥ ५५ ॥ पाकं चिरेण भजते नैव वा त्रिदोषिः पुनः ॥ ५६ ॥
- (अ० ह० नि० ११)
३. रक्तजस्य तु गर्भाशयः स्थानम्-॥ (मा० नि० ३८/२ की मधु० व्याख्या)
४. चण सं० नि० ३/३; अ० सं० नि० ११/४६, का० सं० चि० ९/१८ (पृ० ३८८); चि० ९/२६, २८ (पृष्ठ ३९०) एवं चण सं० वि० ५/१९ की चक्र० टीका (पृष्ठ ४०३)

चिकित्सा के मुख्य तीन उद्देश्य प्रतीत होते हैं:-

१. अनातर्व को दूर करना अर्थात् रजःस्राव कराना ।
२. गुल्म को शिथिल करना ।
३. गुल्म का भेदन ।

चिकित्सा में औषधियों से गुल्म-भेदन न हो पाना, भेदनापानत रक्तमिश्रित तथा अकाल-भेदन के प्रयात में गर्भाशय आघात आदि उपद्रव होते हैं ।

आतर्व शब्द से स्त्रीबीज का ग्रहण किया जा सकता है, स्त्रीबीज की अनुपस्थिति में रक्त के गर्भाशयान्तर एकत्रीकरण, आतर्व आदि गर्भ के लक्षणों का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि बीज की अनुपस्थिति में भी स्त्री को सामान्य ऋतुस्राव कुक्षि-वृद्धि आदि गर्भ के लक्षणों का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि बीज की अनुपस्थिति में भी स्त्री को सामान्य ऋतुस्राव हो सकता है । गर्भाशयान्तर रक्त-सञ्चय एवं गर्भ-भ्रान्ति के लिए अनातर्व होना आवश्यक है अतः यहाँ आतर्व शब्द से रजःस्राव एवं अनातर्व से रजःस्राव न होना मानना ही समीचीन प्रतीत होता है ।

विभिन्न विद्वानों ने रक्तगुल्म को गर्भाशयान्तर रक्त-सञ्चय (हैमेटोमेटर), डिम्बग्रन्थि-अवृद्ध, गर्भाशय के सौत्रिकावृद्ध आदि से सामंजस्य करने का प्रयास किया है ।

गर्भाशयान्तर रक्त-सञ्चय गर्भाशय-ग्रीवा या योनि-नलिका के पूर्ण अवरोध की स्थिति में होता है एवं इस स्थिति में ऋतुमती या नवप्रसूतादि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

डिम्बग्रन्थि के अवृद्धों में सामान्यतया अनातर्व (रक्तगुल्म का एक मुख्य लक्षण) नहीं होता, यदि दोनों ही डिम्बग्रन्थियाँ विकृत हो अनातर्व उत्पन्न भी करें तो यह लक्षण अवृद्धों की काफी वृद्धि के पश्चात् होगा एवं इसे किसी भी प्रकार योनिमार्ग से भेदन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता । सभी आचार्यों ने स्पष्ट रूप से इस व्याधि का स्थान गर्भाशय ही वर्णित किया है जब कि डिम्बग्रन्थि के अवृद्ध गर्भाशयभर स्थित होते हैं । डिम्बग्रन्थि के अवृद्धों की उत्पत्ति रक्त (आतर्व रूपी रक्त) के सञ्चय या विकृति से नहीं होती, जब कि रक्तगुल्म में ऋतुस्राव के काल में रक्त संचित न होकर एकत्र हो गुल्म का स्वरूप ले लेता है ।

गर्भाशय के सौत्रिकावृद्ध या अन्य अवृद्ध मांस-धातु एवं सौत्रिक तन्तुओं से निर्मित होते हैं न कि रक्त से एवं इनके उत्पन्न होने पर रक्तमिश्रवृत्ति होती है न कि अनातर्व, एवं इन्हें भी औषधि से भेदन करके निकालना सम्भव नहीं है । किन्हीं भी प्रकार के अवृद्धों में अकारण या स्वयमेव भेदित होने की प्रवृत्ति एवं भेदित होने पर योनि-पथ से रक्त-साव रूपी लक्षण नहीं मिलते ।

उपर्युक्त तीनों व्याधियाँ शल्य-चिकित्सा-साध्य हैं, औषधि-चिकित्सा साध्य नहीं, जब कि रक्तगुल्म औषधि चिकित्सा-साध्य व्याधि है; अतः उपर्युक्त तीनों व्याधियों को रक्तगुल्म के समकक्ष रखना उचित प्रतीत नहीं होता ।

सामान्य रूप से रक्तगुल्म के अन्तर उन सभी व्याधियों को जिनमें अनातर्व एवं उसके साथ ही च्युरातिसार, शूल, कास, श्वसादि लक्षण हों एवं जिनका प्रादुर्भाव ऋतुस्राव, प्रसव, योनिरेग, योनि-लेजनादि के बाद होने की अधिक सम्भावना हो, रखा जा सकता है । गर्भाशय या प्रजनन-संस्थान के तीव्र शोथ उत्पन्न करने वाली व्याधियाँ इस वर्ग में रखी जा सकती हैं क्योंकि गर्भाशय के अतार्त्तिक शोथ के कारण गर्भाशयान्तःकला विकृत हो अनातर्व तथा आन्त्र-विशेष हो अतिसारादि पाचन-संश्लेषण के लक्षण एवं उपसर्ग के कारण च्वर, श्वस, कासादि हो सकते हैं तथा योनि से दुर्गन्धित स्राव भी उत्पन्न रहते हैं । किसी भी आतार्त्तिक या तीव्र व्याधि की उपस्थिति में सामयिक अनातर्व हो जाने से स्त्री को गर्भ-भ्रान्ति की आशंका कम रहती है एवं इस परिस्थिति में चिकित्सा प्रधान व्याधि की ही की जायगी न कि गुल्म-भेदक ।

जौणकालिक क्षयरोग में च्युरातिसारादि सामान्य लक्षण एवं दौर्बल्य तथा कार्य के कारण अनातर्व मिल सकता है; जौण व्याधि होने के कारण अनातर्व होने पर गर्भ-भ्रान्ति हो, स्त्री को दौहदादि सभी गर्भ के लक्षणों की प्रतीति हो सकती है एवं ऋतुस्राव काने के लिए अनातर्व की चिकित्सा भी की जाती है, अतः किसी सीमा तक यह स्थिति रक्तगुल्म से

सामंजस्य रखती है । परन्तु इस व्याधि में रक्त का कहीं भी संचय नहीं होता, वह गर्भाशय में बनता ही नहीं, जब कि महर्षि काश्रय ने स्पष्ट लिखा है कि 'गुल्म या चय' 'रक्त या रुधिर' अर्थात् रुधिर के एकत्र होने के ही कारण इस व्याधि का नाम रक्तगुल्म है^१ । चिकित्सक को गर्भाशय-परीक्षण से उसमें किसी भी वस्तु का एकत्रीकरण नहीं मिलेगा तथा उसे गर्भ से भ्रान्ति का प्रश्न ही नहीं उठेगा, अतः क्षयज-अनातर्व को भी रक्तगुल्म मानना उचित नहीं है ।

अनातर्व, गर्भ-भ्रान्ति, चिकित्सा-काल एवं भेदन-चिकित्सा के आधार पर इस रक्तगुल्म को गर्भ-मोल के समकक्ष रख सकते हैं । कॉनियस एवं हाइड्रोटेडिफॉर्म दोनों ही प्रकार के मोल में प्रारम्भ में अनातर्व एवं गर्भ के सभी लक्षण हो, पश्चात् योनि से यदा-कदा रक्तस्रावादि लक्षण होते हैं । यदि कुछ उपसर्ग हो जाय तो च्वर, कास तथा योनि से दुर्गन्धित स्राव एवं अतिसारादि लक्षण देखने को मिल सकते हैं । मोल में गर्भ की आकृति विकृत हो एक गुल्म का रूप धारण कर लेती है एवं गर्भाङ्ग अधिकशतः देखने को नहीं मिलते, पर कभी कभी गर्भाङ्ग उपस्थित भी रहते हैं, सम्भवतः इसी द्वैविध्य के कारण अष्टांगसंग्रहकार ने शुक्र-सहित या शुक्र-रहित आतर्व के अवरोध का वर्णन किया है (पृष्ठ ३९०, ३९१) । सशुक्र या अशुक्र लिखने में मूल कारण गर्भङ्गों की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही रहा होगा । इस मोल व्याधि की भेदन चिकित्सा ही मुख्य चिकित्सा है । कॉनियस मोल में अधिकशतः प्रथम गर्भाशय बढ़कर फिर घटता है जिसका स्पष्ट निर्देश महर्षि सुश्रुत ने 'चयापचयवान्' शब्द से किया है ।

रक्तगुल्म के निदान, लक्षण चिकित्सादि का समष्टि रूप से अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक विज्ञान में वर्णित वे सभी व्याधियाँ जिनमें स्थानिक या सावर्दीहिक कारणों से अनातर्व हो, रक्तगुल्म में अन्तर्निहित हो जाती हैं । विविध रूप से यह गर्भ-मोल का वर्णन प्रतीत होता है । 'चयापचयवान्' वर्णन कॉनियस मोल की ओर इंगित करता है, पर यदि गुणित या गूढ़-मूलता, अत्यधिक विस्तार, ह्रस्वता, वमनादि लक्षण तथा असञ्चयता के लक्षणों का विचार करें तो यह हाइड्रोटेडिफॉर्म मोल के समकक्ष प्रतीत होता है, क्योंकि हाइड्रोटेडिफॉर्म मोल में गुणित या गूढ़मूलता के कारण कभी कभी पूर्ण निष्कासन सम्भव नहीं होता; वह पुनः पुनः बढ़ता रहता है, वमनादि लक्षण सामान्य गर्भ से भी अधिक होते हैं तथा यातकावृद्ध में परिवर्तित होने की क्षमता होती है, अर्थात् रक्तगुल्म दोनों ही प्रकार के गर्भ-मोल को अन्तर्निहित करता है ।

Literally word *gulma* means clump or cluster or bush. It arises due to aggravaation of wāy, which either alone or in association with other *dosas* gets accumulated in respective locations of *dosas* or at some other place. Location of *gulma* is in between *hrdaya* (heart) and *basti* (urinary bladder). It has shape of a *granthi* (gland), is mobile or immobile, increases or decreases in size and is circular in appearance.

Just like bush its root or base is hidden and the size is big. Dhalpapa opines that sometimes *gulma* increases and then decreases in size and sometimes initially gets stabilized and then increases in size. *Gulma* either does not get suppurated or very rarely suppurates because the *dosas* get accumulated in their own normal or physiological places.

Considering *raktagulma* in the perspective of above mentioned description of general *gulma*, it appears that *raktagulma* occurs in the uterus (as the place of *rakta* as well as specific location is uterus) due to accumulation of *rakta*. It is circular or just like bush in shape, is spreaded or involves larger area, decreases in size after initial increase and occurs only in the woman of middle age having normal menstrual cycle. Etiopathogenesis of *raktagulma* is different from other *gulmas*.

१. गुल्मश्चय इति श्रौको रक्तं रुधिरमुच्यते ॥ ४० ॥

रक्तस्य सञ्चयस्तेन रक्तगुल्म इति स्मृतः ॥ ४१ ॥ (का० सं० वि० ९)

Before attempting any congruence it would be better to revise in short the description of *raktagulma* available in different books.

Raktagulma is a disease having accumulation of only blood within the uterus, in the women of active reproductive age, having normal menstruation. Aggravated *vāyu* withholding *ārtava* with or without *śukra* accumulates it every month. Vitiation of *vāyu* due to use of dietetics capable of aggravating *vāyu* during puerperium, menstruation (*irukāṇa*) or when suffering from gynecological disorders (*yonirogas*); use of *yonī-stambhan* (astringent) or *yonī-lekhana* (capable to induce curettage) drugs and presence of *yonirogas* are the causative factors of *raktagulma*. Entire clinical features can be grouped under four headings in following way:—

- i) General :— Fever, cough, pain, bodyache, sleepiness, lethargy, stillness, edema of feet, unconsciousness, drooping of eyelids, anemia, emaciation, glands over the abdomen etc.
 - ii) Pertaining to digestive system :— Colic, nausea, vomiting, diarrhoea, anorexia, and indigestion etc.
 - iii) Relating to pregnancy :— Breast changes, increase in size of uterus, delayed quivering with pain and movement like a solid mass, *dohrida*, appearance of lineanigra etc.
 - iv) Pertaining to reproductive system :— Amenorrhoea, pain in uterus, foul smelling vaginal discharges and accumulation of *rakta* in the uterus, sometimes spontaneous expulsion without any apparent cause, in expulsion bleeding per-vaginam.
- Out of all these amenorrhoea and other features resembling pregnancy are most important.

Treatment is aimed to :—

- i) Cure amenorrhoea or induce menstruation.
- ii) Loosen the *gulma*.
- iii) Expel the *gulma*.

The complications are sometimes non-expulsion of *gulma* with medicine thus requiring surgical interference, excessive bleeding per vaginam during or after its expulsion and injury to the uterus if treated in inappropriate time.

With the word *ārtava* ovum can be considered. In the absence of ovulation, the question of accumulation of blood in the uterus, increase in size of abdomen and uterus and other features of pregnancy does not arise, however the woman may continue to have normal menstrual cycle. For accumulation of blood in the uterus and suspicion of pregnancy-amenorrhoea is essential symptom, thus in this reference, considering *ārtava* as menstruation, its absence or amenorrhoea should be taken.

Previous workers have tried to interpret this *raktagulma* as haematometra, ovarian tumours and uterine tumours (fibromyomas) etc. Before giving own opinion it is better to examine the opinions of others.

Haematometra arises due to imperforated hymen, complete stenosis of vaginal canal or cervix uteri. In these conditions question of woman being *ritumati* (menstruating) or having recently undergone a labour does not arise. Haematometra requires surgical treatment not the medical.

Ovarian tumours are usually not associated with amenorrhoea, however, bilateral tumours involving entire ovarian tissue can cause amenorrhoea. The ovarian tumours are not situated within the uterus, can not be treated medicinally and can not be got expelled vaginally, moreover ovarian tumours are not caused due to abnormality or collection of menstrual blood while *raktagulma* develops due to accumulation of unexcreted *rakta* i.e. menstrual blood.

Fibromyomas or other uterine tumours are usually associated with menorrhagia rather than amenorrhoea, moreover, these are made up of muscle-fibres with fibrous tissues not of blood, and can not be treated medicinally.

Tendency of spontaneous vaginal expulsion is not seen in tumours.

All the three diseases mentioned above require surgical treatment, medicinal treatment has no place, while *raktagulma* is mainly treated with oral or local medicines.

Considering all the points none of the above mentioned three disorders can be simulated with *raktagulma* and some other congruence has to be attempted.

Normally all those conditions arising after menstruation, labour, uterine curettage or other *yonirogas* (gynec disorders), having cardinal symptom as amenorrhoea in association with fever, diarrhoea, colic, cough, and dyspnoea etc. can be considered under *raktagulma*. Most important condition of this category is acute infective or inflammatory disorders of uterus (pyometra) and its adnexa. Due to acute inflammation of endometrium there may be amenorrhoea (as seen in pyometra), the pelvic congestion may produce diarrhoea due to hyper-stimulation of bowels. The existing infection can produce fever, cough, dyspnoea and parenteral diarrhoea along with foul smelling vaginal discharges. Amenorrhoea associated with any acute disorder is transitory and will not give the symptoms of pregnancy. The treatment has to be given for actual disease and not to expell the *gulma* or in other words the condition does not simulate *raktagulma*.

Chronic tuberculosis is associated with fever, diarrhoea etc. and due to weakness and emaciation there may be amenorrhoea. Due to chronic nature of disease this amenorrhoea can produce the symptoms of pregnancy or pseudocyesis and treatment may also had to be given to induce menstruation. Thus this condition resembles to certain extent with *raktagulma*, however, in this condition the blood is not accumulated in uterus, rather it is not formed at all. The accumulation of blood is basic criteria for diagnosis of *raktagulma*. As nothing is accumulated in the uterus, so the physician will not find enlargement of uterus and will not consider it as *raktagulma*.

Due to presence of amenorrhoea, suspicion of pregnancy, period of treatment and medicines prescribed for its expulsion; molar pregnancy seems to resemble *raktagulma*. In

molar pregnancy there is initial amenorrhoea and presence of all the clinical features of pregnancy followed by recurrent bleeding per vaginum. Due to association of infection, the fever, cough and foul smelling vaginal discharges can be seen. The product of conception assumes shape of rounded mass or bunch of grapes in carneous or hydatiform mole respectively. The trace of exact fetus is rarely found.

Probably due to findings of both types of mole i.e. with evident fetus or fetal parts and without evident fetus or fetal parts Vāgbhata expounded the theory of *āriava* accumulating with *śukra* (with fetus) or without *śukra* (without fetus). Principle of treatment of molar pregnancy is to get it expelled. In carneous mole uterus decreases in size after initial increase which is described by Suśruta as *carya* (accumulation) followed by *apacarya* (decrease).

Taking into account etiopathogenesis and clinical features of *raktagulma*, all the local (relating to reproductive system) and general conditions described in modern medicines giving rise to amenorrhoea can be considered under *raktagulma*. However, *raktagulma* seem to be specifically analogous to molar pregnancy. Initial increase followed by decrease hint towards carneous mole; while hidden root, excessive enlargement and association of severe nausea and vomiting etc. towards hydatiform mole. Due to its hidden root some times complete expulsion does not take place and recurrence of bleeding or reappearance of vesicles is noted. It may get changed into malignancy and give symptoms described for incurable *gulma*.



अध्याय ८

CHAPTER VIII

प्रसव-विज्ञानीय (सामान्य एवं विकृत प्रसव) (EUTOCIA AND DYSTOCIA OR NORMAL AND ABNORMAL LABOUR)

सामान्य प्रसव-काल (Gestational period for normal labour)

(अष्टमे मासि—) । तस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेऽपि नवमं मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुः दशमान्मासात् । एतावान् प्रसवकालः वैकारिकमतः परं कुक्षावस्थानं गर्भस्य । (च० सं० शा० ४/२५)

नवमदशमेकादशदशानामन्यतमस्मिन् जायते । अतोऽन्यथा विकारी भवति । (सु० सं० शा० ३/३०)

(अष्टमे—) । तस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेऽपि प्रसवकालमाहुः सप्तमासात् । अतः परं विकारी भवति ।

(अ० सं० शा० २/३०)

(अष्टमे—) ।

तस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेऽपि कालः सूतेतः परम् । वर्षाद्विकाराकारी स्यात् कुक्षौ वातेन धारितः ॥

(अ० ह० शा० १/६६)

दशमासं गर्भवासः । (का० सं० शा० १/२२) ।

नवमादिषु मासेषु जन्म—॥ (का० सं० शा० २/११)

अष्टम मास के पश्चात् एक दिन भी व्यतीत हो जाने पर नवें मास से लेकर दशम मास तक प्रसव-काल कहा जाता है । यह सामान्य प्रसव-काल है । इसके पश्चात् गर्भ का कुक्षि में रहना वैकारिक माना जाता है ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि नौवें, दशवें, ग्यारहवें तथा बारहवें किसी भी मास में प्रसव होता है । इसके अनन्तर (बारहवें मास के बाद प्रसव होना) विकारी होता है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि (आठवें मास के पश्चात्) एक दिन निकल जाने पर वर्ष पर्यन्त या बारहवें मास तक प्रसव-काल कहा जाता है । इसके पश्चात् वह विकारी होता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने उपर्युक्त मतों का ही प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि (आठवें मास के पश्चात्) एक दिन व्यतीत होने पर भी (नवम मास के प्रथम दिन से लेकर) वर्ष (१२ माह) तक प्रसव-काल होता है । उसके पश्चात् वायु द्वारा रोका हुआ गर्भ विकाराकारी होता है ।

महर्षि काश्यप का कथन है कि कलियुग में मनुष्य के गर्भवास का काल दस मास है । इन्होंने अन्य युगों के मनुष्यों के गर्भवास-काल का वर्णन दिया है जो अप्रसङ्गिक होने से अनुद्भूत है; पुनश्च नवम आदि मासों को जन्म-काल माना है ।

महर्षि हारीत ने दशम एवं एकादश मास में,^१ आचार्य भावमिश्र^२ तथा योगरत्नाकर ने^३ भी नवम से बारहवें मास तक का प्रसव-काल माना है।

महर्षि चरक ने नवें एवं दशवें दो मास, हारीत ने दशवें-ग्यारहवें दो मास तथा अन्य सभी ने नौवें से बारहवें चार मास को प्रसव-काल माना है। टीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि नवम एवं दशम मास तो अत्यधिक उत्तम प्रसव-काल है, परन्तु एकादश एवं द्वादश में भी अत्यल्प दोष होने के कारण उन्हें भी सामान्य प्रसव-काल के सदृश ही समझना चाहिए।^४

From the first day of ninth month upto tenth month is normal period of labour; intra-uterine stay of fetus beyond this limit is abnormality, this is the view of Charaka and Kāśyapa. Suśruta, both Vāgbhaṭas and others are of the opinion that from first day of ninth month upto twelfth month is the period of normal labour, stay of fetus beyond this limit is an abnormality caused by vitiated vāyū. Cakrapāṇi has clarified that best period for labour is ninth and tenth month, however, since in the eleventh and twelfth month the amount of abnormality is very less, thus these can also be considered within normal limits.

विमर्श (Comments)

सामान्य प्रसव-काल दशम मास का प्रथम पक्ष माना जाता है, परन्तु इस प्रक्रिया में अत्यधिक व्यक्तित्व वैभिन्य मिलता है। आयुर्निक विज्ञान-वर्णन-दृष्ट्या संहिताओं में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों ही सीमायें अमान्य हैं। नवें मास का प्रसव अप्राप्य शिशु-जन्म तथा दशवें के अंतिम चरण से लेकर बारहवें मास तक का अतिप्राप्य शिशु-जन्म माना जाता है। इस सामान्य प्रसव-काल के अपवाद आयुर्निक काल में भी उल्लिखित हैं यथा सम्भोग की तिथि के ३३९ (ग्यारहवाँ मास), ३४९ (बारहवाँ मास) एवं ३६० दिन (पूरे बारह मास) के बाद भी सामान्य या स्वस्थ शिशु का प्रसव एवं एनसेफैलित बाल से पीड़ित गर्भ का ३८९ (एक वर्ष २४ दिन) दिनों तक भी जीवित अवस्था में ही गर्भाशयान्तर वास।^५

इस वर्णन के निम्नलिखित सम्भाव्य कारण हो सकते हैं:-

१. स्तन-पात्र काल में उपस्थित अनर्तव्य या अन्य किसी कारण जन्म अनर्तव्य-काल में गर्भाधारण हो जाने से वास्तविक गर्भाधारण के काल के ज्ञान का अभाव।
२. ऋतुचक्र का सामान्य से अधिक अवधि का होना:-कभी कभी किसी विशिष्ट विकृति के ही स्त्रियों का ऋतुचक्र सामान्य से अधिक (४५ से ६० या ९०) दिवसों का होता है। ऋतुचक्र में स्त्रीबीजोत्सर्ग रजःस्राव प्रारम्भ होने के १४-१५ दिन पूर्व ही होता है, अतः दीर्घकालिक ऋतुचक्र वाली स्त्रियों में अनर्तव्य-काल से गणना करने पर गर्भाधारणकाल सामान्य से अधिक काल का प्रतीत होगा।
३. अनर्तव्य-काल की गणना में त्रुटि:-कुछ स्त्रियाँ गर्भाधारण के प्रथम मास को भी गिन लेती हैं, उदाहरणार्थ अंतिम रजःस्राव फरवरी में होने पर गर्भाधारण का प्रथम मास मार्च से गिना जायगा परन्तु वे फरवरी को प्रथम मास मानकर मार्च को द्वितीय मास गिन लेती हैं, जिसके कारण एक मास का अन्तर पड़ जाता है।

मानकर मार्च को द्वितीय मास गिन लेती हैं, जिसके कारण एक मास का अन्तर पड़ जाता है।

१. दशमें च प्रसूते तथैकादशमेऽपिवा ॥ (शो सं० षष्ठस्थान १/२३)
२. नवमें दशमे मासि नारी बालं प्रसूते । एकादशे द्वादशे वा ततोऽन्य विकारतः ॥ ३०८ ॥
.....नारी गर्भं प्रसूते॥ (भा० प्र० पूर्व ३/३०८ एवं ३४० तथा चि० ७७/१०२)
३. नवमें.....नारी गर्भं॥ (शो सं० स्त्रीरोग चि०, भा० प्र० सदृश ही)।
४.॥ आद्यमादिनि च वचनं प्रसूतप्रसवकालाभ्याप्येण । सुश्रुते द्विदशमासपर्यन्तं समयकसवकालाभ्यापनं स्तोकोद्योष्यो-
रेकादशद्विदशमासयोस्तदोष्यतेनाद्योष्येण ॥ (चो सं० शा० ४/२५ की चक्र-टीका)
५. मुनोकर की ऑपरेटिव ऑब्सेट्रिक्स । (पृष्ठ ६२०, ६२१)

४. हमारे देश में अधिकांश मास ३० दिन के न होकर कम दिनों के होते हैं, जिसके कारण सामान्य प्रसवकाल के २८० से २८९ दिन लगभग दश मास या इससे कुछ अधिक दिनों में ही पूर्ण होते हैं न कि ९ मास ७ दिन में।
५. यदि उपर्युक्त वर्णित एक से अधिक कारण एक साथ उपस्थित हो जाँय तो सामान्य गर्भ होते हुए भी स्त्री अथवा सिकरिस्तक उसे एकादश या द्वादश मास का भी मान सकती हैं।
६. प्रसव-काल में अत्यधिक व्यक्तित्व वैभिन्यता की उपस्थिति।
७. अपवाद की स्थितियों का भी सामान्य स्थिति में समावेश।
८. एनसेफैलित पीड़ित गर्भ के दीर्घकालीन गर्भाशयान्तर वास की स्थिति का भी सामान्य प्रसव-काल गणना में ही समावेश।

Minimum and maximum duration of gestation considered as normal for labour in *āyurvedika* classics is not acceptable to-day, because the delivery in the beginning of ninth month is termed as premature and after second week of tenth month as postmature. However, in exceptional cases intrauterine stay of normal fetus (after probable date of cohabitation) for 331, 349, and 360 days and of alive but anencephalic fetus for no less than 389 days has been mentioned in operative obstetrics.¹ This difference might have appeared due to following reasons:-

- Pregnancy occurring during lactational amenorrhoea or other secondary amenorrhoeas resulting in ignorance about exact month of impregnation.
- Prolongation of normal menstrual cycle:—Some times without any specific abnormality menstrual cycle is prolonged for 45-60 or 90 days etc. Ovulation occurs mostly 14-15 days prior to the onset of menstruation. If conception occurs in such cycle the gestational period may appear to be prolonged beyond a normal limit.
- Miscalculation of amenorrhoea period:—Few women count month of last menstrual period as first month of pregnancy, for example a woman having her last menstruation in February will count Feb. as first month of pregnancy and March as second. This results in difference of one month in duration of gestation.
- Lunar months are not of thirty days rather usually of twentyeight days, thus 280-287 days described for normal labour cover the period of ten months or more, not of only nine calendar months + 7 days.
- More than one factor described above operating together may give false impression of normal labour occurring in eleventh or twelfth month.
- There are great individual variations in duration of normal gestation.
- Consideration of exceptions under general rule.
- Consideration of prolong intrauterine stay of anencephalic fetus under normal duration of labour.

प्रसव प्रारम्भ होने के कारण (Causes of onset of labour)

कालस्य परिणामेन मुक्तं वृन्ताद्या फलम् । प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा पतितुं शुक्लम् ॥
एवं कालप्रकर्षेण मुक्तो नाडीनिबन्धनात् । गर्भाशयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते ॥
(सु० सं० नि० ८/७, ८)

काल के प्रभाव के कारण वृन्त से मुक्त हुआ फल जिस प्रकार स्वभाव से ही पतित होता है अन्यथा नहीं, उसी प्रकार काल के प्रकर्ष से नाड़ी-निबन्धनों से मुक्त हुआ गर्भाशयस्थ गर्भ प्रसव के लिए उद्यत होता है ।

महर्षि हारीत^१ ने गर्भ का गर्भाशय-वास से वैराग्य होना तथा भेल ने रस के द्वारा पोषण होकर सम्पूर्ण नाव का हो जाना ही प्रसव का कारण माना है ।

Susruta says that as a fruit getting detached from its stalk due to time factor comes down naturally, similarly *garbha* in its appropriate time, getting detached from its *nāḍī-nibandha* proceeds for labour due to its specific nature. Development of indifference by fetus from its intrauterine stay and attainment of full maturity of different body-parts by fetus are the causes mentioned by Hārīta and Bhela respectively.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सभी कारणों का समष्टि रूप से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आचार्यों ने नाड़ी-विबन्ध-मुक्ति, स्वभाव, गर्भ-वास-वैराग्य, सम्पूर्णता तथा काल-प्रकर्ष आदि पंच कारणों का उल्लेख किया है । जिनका स्मष्टीकरण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है ।

१. नाड़ी निबन्ध-मुक्ति—नाड़ी शब्द दो अर्थों का द्योतक है (१) संज्ञावह नाड़ी-तन्तु (२) गर्भ की रसवहा नाड़ी, एवं इनके निबन्ध की मुक्ति अर्थात् इनके कार्य में बाधा की मुक्ति अथवा इनके मार्ग-शरीर या गर्भाशय स्थित बन्धनों की मुक्ति ।

गर्भाशयस्थ के काल में गर्भाशय में मांसपेशी तन्तुओं को उत्तेजित करने वाले अङ्गुस पिटीसिन के कार्य को निष्क्रिय करने के लिए पाइटीकाइनेज नामक एन्जाइम उत्प्रेषित रहता है अर्थात् गर्भाशयोत्तेजक नाड़ी के कार्य में निबन्ध या अवरोध रहता है । प्रसव के कुछ काल पूर्व ही यह पाइटीकाइनेज समाप्त होता है एवं पिटीसिन के प्रभाव के कारण गर्भाशय उत्तेजित रहता है । प्रसव कर गर्भ का प्रसव कराता है, अर्थात् नाड़ी-निबन्ध समाप्त होने के कारण प्रसव होता है ।

हो संकोच प्रारम्भ कर गर्भ का प्रसव कराता है, अर्थात् नाड़ी-निबन्ध समाप्त होने के कारण प्रसव होता है । गर्भ की रसवहा नाड़ी अपना से सम्बन्धित रहती है । गर्भाशयस्थ के अंतिम चरण में अपना में स्थान-स्थान पर इन्फॉक्ट बनने के कारण उसके कार्य में बाधा होती है जिससे गर्भ की आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो प्रसव का एक कारण है अर्थात् गर्भ की पोषक रसवहा नाड़ी से सम्बन्धित अपना एवं मार्ग-शरीर के बीच स्थित निबन्धों या कार्यप्रणाली में क्षीणता आती है एवं प्रसव होता है ।

२. स्वभाव—प्राकृतिक कार्य या अज्ञात-कारण ।

३. गर्भ-वास-वैराग्य — गर्भ के अन्दर स्वयं के परिवर्तन यथा गर्भ की आक्सीजन-न्दूना अथवा गर्भ-शरीर-उपस्थित अङ्गुरासों का प्रभाव जो प्रसव का कारण माना जाता है ।

४. गर्भ-सम्पूर्णता — सामान्यतया गर्भ के पूर्ण होने पर उपर्युक्त सभी कारण एक साथ कार्य करते हैं एवं प्रसव का प्रारम्भ हो जाता है ।

१. जायते तस्य वैराग्यं गर्भाशयस्थ कारणम् । (हि० सं० षष्ठस्थान ४/२३)

२. सम्पूर्णं गात्रो भवति यदा स रसभाविनः । तदा प्रसौत्यन्धकाशं (लं) गर्भः स्त्रीकुक्षिनिच्युतिः ॥ (धे० सं० शा० ३/१३)

५. काल-प्रकर्ष—गर्भाशयस्थ के एक निश्चित काल के पश्चात् ही शरीर में प्रसवोपयोगी परिवर्तन होते हैं यथा विक्रियत इन्फॉजन स्वतंत्र हो गर्भाशय की मांसपेशियों को पिटीसिन की क्रिया के लिए सुग्राही बनाकर गर्भाशयोत्तेजना में सहायक होता है । गर्भाशय-मांसपेशी में ऑक्सेमार्गीसिन अपनी अधिकतम सीमा में एकत्रित हो मांसपेशी-तन्तुओं का संकोच उत्पन्न करता है । गर्भाशय अधिकतम सीमा तक विस्तृत हो संकुचित होना प्रारम्भ कर देता है आदि । यह सभी परिवर्तन काल पर ही आधारित होते हैं ।

Detachment of *nāḍī-nibandha*, *swabhāva* (nature), indifference of fetus from intra-uterine stay, full maturity of fetal parts and time factor are the five causes enlisted as responsible for labour. All these can be explained in the following way:—

i. Detachment of *nāḍī-nibandha*—*Nāḍī* word denotes sensory or motor nerve fibres and umbilical cord. Release or detachment of *nibandha* means release of obstruction in their normal functions or detachment of attachments situated between *nāḍī* and maternal body or uterus.

Piocrinase enzyme inhibits the action of piocin during pregnancy or this enzyme inhibits the myometrial stimulation, a normal function of motor fibres of nerves. Few days preceding labour this piocrinase disappears allowing the piocin to act, thus motor fibres of nerves stimulate myometrium, or in other words obstruction in function of nerves (*nāḍī*) is released.

The umbilical cord derives its nourishment from placenta, to which it is attached. As the term approaches infarcts appear at maternal side of placenta which hamper free flow of oxygen causing anoxia to the fetus, a cause of labour. In other words attachments situated inbetween umbilical cord (*rasavahānāḍī*) or placenta and maternal body or uterus are detached which initiate labour.

ii. *Swabhāva* (Nature)—Unknown cause.

iii. *Garbha-vāsa vai-rāgya* (Indifference of the fetus from its intra-uterine stay)—Changes in the fetus caused due to anoxia, and its hormones initiate labour.

iv. *Garbha sampūrṇatā* (Full maturity of fetal parts):—Generally above mentioned factors operate together only when the fetus is mature and then delivery of full term fetus occurs.

v. *Kāla prakaraṣa* (Time factor)—After a specific period of gestation, changes necessary for labour occur in the body, such as estrogen inactivated due to conjugation becomes free and sensitizes myometrium for the action of piocin, thus helps in myometrial stimulation. Actomyocine also gets optimum deposition and starts contraction of myometrial fibres. Uterus attaining its maximum distension starts contraction. All these changes occur after a specified period.

सूतिकागार (Sutikāgāra or accouchement ward)

सभी संहिताओं में प्रसव के समय स्त्री को एक पृथक् गृह का निर्माण कर उसमें रखने का निर्देश दिया गया है । सम्भवतः ये गृह प्रत्येक प्रसूता के लिए नवनिर्मित करके पुनः समाप्त कर दिये जाते होंगे ।

In every classic one finds the description of accouchement ward, probably these were

constructed for every parturient woman and dismantled afterwards.

सूतिकागार की आकृति एवं निर्माण-विधि (Shape, size and method of construction of accouchement ward)

प्राक् वैवास्या नवमान्मासात् सूतिकागारं कारयेदपह्नातिस्थिराकारकापाले देशे प्रशस्तरूपरसाग्न्यायां भूमौ प्राद्वारमुद्वारं वा बैलवानां काष्ठानां तैन्दुकैर्बुदकानां भाल्लातकानां वारं (रु)णानां खादिराणां वा; यानि चान्याय्यि शस्त्रेयुधवैदिवदस्तेषां, वसनालपानाच्छान्नाभिधानसंपदुपेतं वास्तुविद्याद्वययोगानिर्मातृदूखलव-
र्तःस्थानान्भूमिमेतानमुत्तुसुखं च ॥ (च० सं० शा० ८/३३)

तत्रादिष्ठं ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणां श्वेतारकपीतकृष्णेषु भूमिप्रदेशेषु बिल्वव्यग्रोषतिन्दुकभाल्लातकनिर्मित-
सर्वांगारं यथासङ्ख्यं तन्मयपर्यङ्कम् समुपलिम्भितं सुविभक्तपरिच्छदं प्राग्द्वारं दक्षिणद्वारं वाऽष्टहस्तायतं
चतुर्हस्ताविसृतं रक्षामङ्गलसंपन्नं विधेयम् । (सु० सं० शा० १०/५)

प्राग्द्वारस्या नवमान्मासादपह्नातिस्थिराकारकापाले प्रशस्ते देशे वास्तुविद्याप्रशस्तं सर्वतुसुखमुपहृतसर्वोपकाराणां
सन्निहितव्यलनं प्राग्द्वारमुद्वारं वा सूतिकागारं कारयेत् ॥ (अ० सं० शा० ३/१५)

प्राग्द्वारैव नवमान्मासात् सा सूतिग्रहमाश्रयेत् । देशे प्रशस्ते सम्भारेः सम्पन्नं साधकेऽहनि ॥
(अ० ह० शा० १/७३)

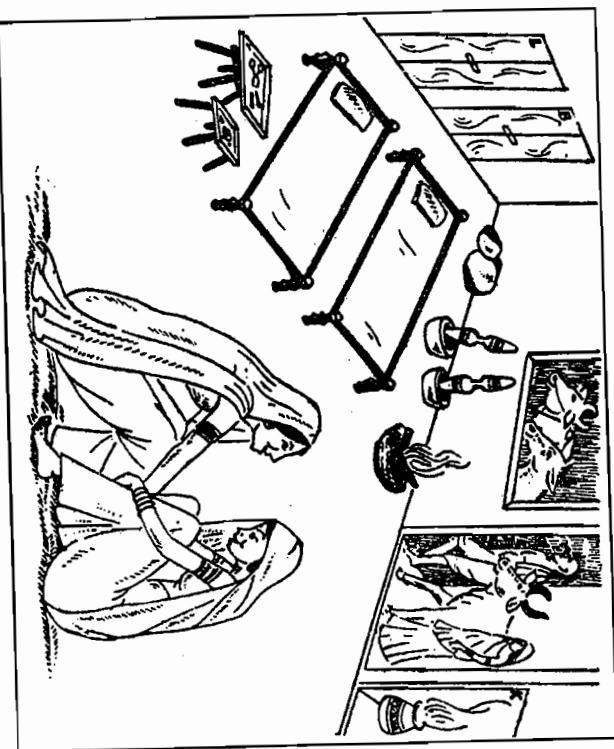


Fig. (7) : *Sutikagāra* (accouchement ward) constructed with the wood, having separate latrine (L), bath room (B) and kitchen (K), containing two beds, two stones, pestle with mortars, burning fire, medicines, instruments and female attendants. A donkey leg and a bull is tethered outside. The pregnant woman is entering advancing her right leg and following *brāhmanā* and cow.

नवम मास से पूर्व ही इसके (गर्भिणी के) लिए अस्थि, शर्करा (कंकड़, बादर आदि) एवं कपाल (मिट्टी के बर्तनों के टूटे टुकड़े) आदि से अपहृत (इन वस्तुओं से रहित या उपस्थित होने पर इनके निकाल देने के बाद), प्रशस्त रूप, रस एवं गन्ध (सुन्दर दर्शनीय, सुगन्धित वृक्षों आदि से युक्त, क्योंकि उचित रस वाली पृथ्वी में वृक्षादि की उत्पत्ति अच्छी होगी) वाली भूमि में, पूर्व अथवा उत्तर की ओर द्वार वाला; बिल्व, तिन्दुक, शृंगूर, भाल्लातक, वरण या वरण अथवा खदिर के काष्ठ से सूतिकाकार का निर्माण करें या अन्य किसी (भी काष्ठ) से जिससे ब्राह्मण या अथर्ववेदशास्त्रा कहें (सूतिकागार) बनावें । (सूतिकागार) वस्त्र, आलेपन (दिवालों आदि का गोबर या चूने से आलेपन), आच्छादन (अच्छी प्रकार आच्छादित या समुचित प्रकार की छत) तथा अधिधान (ढाकने के लिए वस्त्र या छत तथा दरवाजों एवं छिड़कियों को ढकने के लिए वस्त्र, पर्दे या दरवाजे) से युक्त रहे । वास्तु-विद्या जानने वाले विद्वान की राय से अलग-अलग^१ बने अग्नि, जल, उदूखल रखने के स्थान, वर्तःस्थान (शौचघर), स्नानघर एवं रसोदर आदि से युक्त सभी ऋतुओं में सुखकारक (सूतिकागार) बनावें (चि० ७)

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि इस शुभ सूतिकागृह का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत, एवं कृष्ण भूमि प्रदेश में, बिल्व, व्यग्रोष, तिन्दुक एवं भाल्लातक के काष्ठ से निर्माण करें । यह सूतिकागार इन्हीं (बिल्व आदि) की लकड़ी से निर्मित पलांग से युक्त, अच्छी प्रकार लिपी हुई दिवालों वाला, भली भाँति कपड़े आदि (पर्दे आदि) से आवृत तथा यथास्थान व्यवस्थित रूप से रखी वस्तुओं वाला, पूर्व या दक्षिण की ओर द्वार वाला, आठ हाथ लम्बा एवं चार हाथ चौड़ा, रक्षा तथा मंगल द्रव्यों से युक्त होना चाहिए ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि नवम मास से पूर्व ही अस्थि, शर्करा एवं कपाल (अस्थि एवं रोड़े, कंकड़ तथा खपड़े आदि) निकाल दिए हुए, वास्तुविद्या (भवन-निर्माण-कला) में प्रशस्ति स्थान में, सभी ऋतुओं में सुखकारी, सभी उपकरणों से युक्त, बाह्य प्रज्वलित अग्नि-युक्त, पूर्व या उत्तर की ओर द्वार वाला सूतिकागार निर्माण करें । टीकाकार इन्दु ने नवम मास से लेकर अर्थात् नवम मास के बाद सूतिकागृह निर्माण की व्यवस्था बताई है^२ ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी नवम मास के पूर्व ही प्रशस्त देश में सभी उपकरणों से युक्त शुभ नक्षत्र में सूतिकागृह निर्माण करने का निर्देश दिया है ।

महर्षि भेल ने भी लिखा है कि अष्टम मास व्यतीत हो जाने पर तिन्दुक, पलाश या अक्षय की लकड़ी से पूर्व या उत्तर की ओर द्वार वाला सूतिकागार निर्माण करें^३ ।

आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत सदृश ही आचाम का वर्णन दिया है कि आठ हाथ लम्बा एवं चार हाथ चौड़ा, पूर्व या उत्तर की ओर द्वार वाला सूतिकागार बनावें^४ ।

An abode for expectant woman should be constructed before ninth month of pregnancy on a land free from stone, sand or gravel and pieces of broken earthen pots (either already absent or removed before construction), and having excellent appearance, *rava* (taste i. e. land should not be salty etc.) and smell (not having foul smell etc.). The house should face east or north and be constructed with the wood of any tree out of *bilva*, *tinduka*, *inguda*, *bhallātaka*, *varuna* or *khadiya* or with any other wood advised by *brāhmanas* or the persons having knowledge of *ātharvaveda*. The house should be well clothed, smeared with cow dung or lime, covered or roofed (with roof of wooden frame) and curtained or having well

१. अधिधानं कपाटम् ।वास्तुविज्ञानेन विभक्तान्यादिस्थानम्॥ (च० सं० शा० ८/३३ की चक० की टीका)

२.नवमान्मासात् प्रपुति॥ (अ० सं० शा० ३/१५ की इन्दु टीका)

३. अष्टमे तु खलु मासे प्रतिविहिते सति सूतिकागारं सम्पक् प्राद्वारमुद्वारं वा कारयेत् तिन्दुकपलाशाद्वयैः । (अ० सं० शा० ८/६)

४. अष्टहस्तायतं चारचतुर्हस्ताविसालकम् । प्राचीद्वारमुद्वारं दिग्बालसूतिकागृहम् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३४१)

fitted doors. With the advice of architect specific places to keep fire, water, mortar with pestle along with separate latrine, bathroom and kitchen should be constructed in such a way that the place becomes comfortable in all the seasons (fig.7).

Suśruta says that the accommodation ward for *brāhmaṇa*, *kṣatriya*, *vaiśya* and *śūdra* should be constructed on the land having white, red, yellow or black colour, with the wood of *bilva*, *nyagrodha*, *tinduka* or *blallāṭaka* respectively, i.e. for *brāhmaṇa* on white land with the wood of *bilva* etc. This ward should be furnished with the beds made of these very woods. Its walls should be well smeared and protected with cloth (curtained). All the things should be placed systematically in their proper places. It should be twelve feet long and six feet wide and face to the east or south. *Rakṣā dhravyas* (articles having protective or antiseptic properties) and auspicious articles should be stored in it.

Vāgbhata I giving description like Caraka albeit very short says that flaring fire should be continuously kept in the house. Indu opines that construction of house should be started after beginning of ninth month.

Vāgbhata II agreeing with above views says that construction should be started in auspicious period. In the opinion of Bhela wood of *tinduka*, *palāśa* or *aśwaththa* should be used. Bhāvanāśra has followed Suśruta.

विमर्श (Comments)

सभी आचार्यों ने नवम मास के पूर्व ही मूर्तिकागार के निर्माण की व्यवस्था दी है जिससे यह प्रतीत होता है कि सम्भवतः प्रत्येक प्रसव के लिए नवीन मूर्तिकागार का निर्माण होता था। काष्ठ से मूर्तिकागार-निर्माण के तीन कारण हो सकते हैं (१) आसानी से उपलब्ध (२) उत्कृष्टता से सुरक्षा; क्योंकि काष्ठ में उत्का का प्रभाव नहीं होता (३) कार्य हो जाने पर हटाने में सुविधा। महर्षि सुश्रुत के अतिरिक्त सभी ने इसका द्वार पूर्व या उत्तर की ओर रखने का निर्देश दिया है जो सम्भवतः प्रातःकाल में सूर्य-रश्मि के प्रवेश एवं मध्यान्ह के उत्तरा सूर्य की किरणों के प्रवेश-निषेध की दृष्टि से वर्णित है। सम्भवतः महर्षि सुश्रुत ने मध्यान्ह की सूर्य-रश्मि के प्रवेश को उचित समझकर एवं वायु आदि के समुचित प्रवेश की दृष्टि से दक्षिण की ओर द्वार रखने का निर्देश किया है। महर्षि सुश्रुत एवं भावमिश्र वर्णित आयाम अत्यधिक प्रवेश की दृष्टि से सम्भवतः यह आयाम केवल प्रसव करने के लिए निर्मित कक्ष का हो न कि मूर्तिका के रहने के न्यून प्रतीत होता है, सम्भवतः यह आयाम केवल प्रसव करने के लिए निर्मित कक्ष का हो न कि मूर्तिका के रहने के लिए। महर्षि सुश्रुत-वर्णित जाति-भेद से काष्ठ-पिंडता का समुचित स्पष्टीकरण कठिन है सम्भवतः यह शरीर के वर्ण की दृष्टि से अथवा सूतिकागार-निर्माण में प्रयुक्त काष्ठ के वर्ण को देखकर प्रसूता स्त्री की जाति के ज्ञानार्थ उल्लिखित हो।

As construction of house has been advised before or during ninth month of pregnancy, thus it appears that a new accommodation room/ward was constructed for every parturient woman. Construction with wood might have been advised due to three reasons i.e. easy availability, protection from thunder-bolt because the wood is bad conductor of electricity and easy to dismantle after completion of its purpose. The house facing to the east will have easy access to wind and rays of rising sun, while facing to the north will prevent entry of rays of mid-day hot sun, probably Suśruta might have preferred the entry of rays of mid-day sun and also good air, thus he advised the door of the house to be on south instead of north. The dimensions described by Suśruta seem to be too small for a ward, however, these might be referring to the labour room not to the ward.

(आ) मूर्तिकागार में संग्रहणीय पदार्थ (The articles to be stored in accommodation ward/room)

तत्र सर्पिस्तैलमधुसैन्धवसैवर्चलकालिबिडलतणविडङ्गकुक्षिकलितमनगरपिप्पलीपिप्पलीमृदुहस्तिपिप्पलीमण्डूक-ण्योलाताङ्गुलीवचाव्ययचिरबिल्वहिङ्गुसर्पपलशुनकतककणिकाणीपातसीबल्लजभूर्जकुलतथ्यमैत्रेयसुरासवाः सन्निहिताः स्युः तथाऽश्वामौ द्वौ द्वे कु(च)ण्डमुसले, द्वे उदुखले, खरवृषभश्च, द्वौ च तीक्ष्णोसूचिपिप्लतकी सौवर्णराजतौ, शस्त्राणि च तीक्ष्णायसानि, द्वौ च विल्वमयी पर्यङ्गौ, तैन्दुकहुदानी च काष्ठान्यग्निनसस्यक्षणाणि, स्त्रियश्च बह्व्यो बहुशः प्रजाताः सौहार्दयुकाः सततमसुरता प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्तिकुशलाः प्रकृतिवस्त-लान्स्यकविवादाः क्लेशसहि-योऽभिमतः, ब्राह्मणाश्वयवेदविदः, यज्यान्यदपि तत्र समर्थ मन्यत, यज्यान्यच्च ब्राह्मणा बृहः स्त्रियश्च वृद्धस्तत्कार्यम् ॥ (च० सं० शा० ८/३४)

—सर्वोपकरणं सन्निहितव्यतनं ॥ (अ० सं० शा० ३/१५)

.....सम्भारैः सम्पन्नं। (अ० ह० शा० १/७३)

मूर्तिकागार सर्पि, तैल, मधु, सैन्धव, सौवर्चल, काला एवं विड लवण, विडङ्ग, कुष्ठ, किलिम (देवदार), नागर, पिप्पली, पिप्पलीमृदु, हस्तिपिप्पली, मण्डूकपर्णी, एला, लाङ्गुली, वचा, चव्य, चिरबिल्व, हिङ्गु, सर्षप, लशुन, कतक, कणिकाणिका (विशिष्ट औषधि), तीप, अतसी, बल्लज, भूर्ज (पत्र), कुलतथ्य, मैत्रेय, सूरु एवं आसव से युक्त होना चाहिए, दो पत्थर (के टकरे), दो छोटे या बड़े मूसल, दो उदुखल, खर, वृषभ, दो स्वर्ण या रजत निर्मित तीक्ष्ण सूचीपिप्लतक (सूची सदृश शस्त्र), लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र (प्रसवोपयोगी), बिल्व-निर्मित दो पलङ्ग, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए तिट्ठक तथा इंगुदी की लकड़ी एवं बहुप्रसूता, सौहार्द युक्त, सतत सेवानुत्त, सुन्दर आचरण वाली, प्रसव-कार्य में कुशल, प्रकृतिः प्रेम करने वाली, विषाद से रहित, क्लेश को सहन करने वाली, (प्रसविनी के) मन को प्रसन्न करने वाली स्त्रियों से युक्त हो तथा अश्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण भी वहाँ उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी वस्तु ब्राह्मण या वृद्ध स्त्रियाँ कहें वह वहाँ रखनी चाहिए।

महर्षि वाग्भट (दोनो) ने संक्षेप में लिखा है कि मूर्तिकागार सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त होना चाहिए। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने प्रज्वलित अग्नि को भी रखने के लिए कहा है। अन्यत्र प्रसव करने में कुशल बहुप्रजाला आदि स्त्रियों की उपस्थिति महर्षि चरक सदृश ही वर्णित की है।

महर्षि भेल ने लिखा है कि मूर्तिकागार में दो बिल्वमय पलङ्ग, दो सूप, उदुखल एवं मूसल दो दो, गन्ध-द्रव्य, यवागु, सर्पि, तैल एवं सर्षप पहिले ही एकत्रित कर लें।

Ghṛa, oil, honey; rock, *saṃvārala*, black and vid salt; *viḍāṅga*, *kuṣṭha*, *devadāra*, *nāgāra*, *pipplī*, *pipplīmṛdū*, *hastipipplī*, *maṇḍūkāparṇī*, *elā*, *lāṅgūlī*, *vaca*, *carya*, *citraka*, *cirabīlva*, *hiṅgu*, *sarṣapa*, *lāsūna*, fruit of *kataka*, *kanakāṅkī*, *nīpa*, *ataśī*, *bahvija*, *bhūjāpāra* and *kulathā*, etc. drugs; *maitrēya*, *sūrā* and *āsava* etc. beverages; two pieces of stone, two pestles, two mortars, a donkey, a bull, two needles made of gold or silver, sharp instruments (to be used during labour) made of iron, two beds made with the wood of *bilva*, and woods of *tinduka* and *iṅguḍī* for lighting the fire should be stored in labour ward. Multiparous women who are good-hearted, continuously busy in service, possessing strong

१. किलिमं देवदारः। कणः 'कुण्डक' इति ख्यातः, कणिका तु कुण्डकात् स्थूलास्तण्डुलावयवा उच्यन्ते.....कुण्डमुसले

इति हस्त्वमुसले किंवा चण्डमुसले इति पाठः, तदा गुलतरमुसले इत्यर्थः ॥ (च० सं० शा० ८/३४ की चक्र० टीका)

२. अ० सं० शा० ३/१६ (मूर्तिकागार-निवास विधि में वर्णित)

३. अथवा पूर्वसङ्कल्पिताः स्युः द्वौ खलु (बिल्व)मयी पर्यङ्गौ, सूची च द्वौ, उदुखलमूसलौ, गाङ्गो (स्यो)प (चा)वा (दा)तं, य (वा)गुः सर्पिश्च तैलं च सर्षपाक्षेति ॥ (अ० सं० शा० ८/७)

character, experienced in conducting the labour, with basically affectionate in nature, free from grief, having good endurance, and capable of making parturient woman happy along with *brāhmanas* possessing knowledge of *ātharvaveda* should remain present there. Besides all these other things advised by *brāhmanas* or old ladies should also be stored.

Vāgbhata says that all essential items should be stored. Bhela has enlisted two beds made with the wood of *bliva*, two winnowing baskets, two pestles with mortars, fragrant drugs, rice-gruel, *ghrita*, oil and *sarsapa* in the list.

(इ) सूतिकागार में प्रवेश एवं निवास-विधि (Entry and stay in accouchement ward)

ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रशस्तनक्षत्रयोगपुण्यतः प्रशस्ते भगवति शशिनौ कल्याणे कल्याणे च करणे भेदे मुहूर्ते शान्तिं हुत्वा गोब्राह्मणमग्निमुदकं चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्सुणोदकं मधुलानांश्च प्रदाय ब्राह्मणेभ्योऽक्षतान् समनसो नान्दीमुखानि च फलानोऽष्टानि दत्त्वादेकपूर्वमाससन्धेभ्योऽभिवाद्य पुनराचम्य स्वीत्स्न वाचयेत् । ततः पुण्याहशब्देन गोब्राह्मणं समनुवर्तमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत् सूतिकागारम् । तत्रस्था च प्रसवकालं प्रतीक्षेत् ॥
(च० सं० शा० ८/३५)

नवमे मासि सूतिकागारमेतं प्रवेशयेत् प्रशस्ततिथ्यादौ ॥ (सु० सं० शा० १०/५)

तत्रानुक्रमेण नक्षत्रादिषु पुण्याहशब्देन गोब्राह्मणवृद्धाब्रह्मज्ज्वलमाना प्रदक्षिणं प्रविश्य बहुशः प्रसूताभिरनुताभिश्चविधाभिः क्लेशक्षमाभिः परिहृता स्वस्वयनपराजुलौभैरहासविहारैरनुलोमितवातमूत्रपुरीषा प्रसवकालमुदीक्षेत् । स्वलोऽपि च विष्णुमूर्तिवन्द्यं फलवतीः प्रणिदध्यात् ॥ (अ० सं० शा० ३/१६)

सायकेऽहनि ॥ ७३ ॥

तत्रोदीक्षेत् सा मूर्ति सूतिकापरिवारिता ॥ ७४ ॥ (अ० ह० शा० १)

(गर्भिणी) नवम मास के प्रारम्भ हो जाने पर पुण्य दिन में, भगवान् चन्द्रमा का योग शुभ नक्षत्रों, उच्चस्थान तथा कल्याणकारी-करण होने के काल में तथा भैत्र मुहूर्त में शान्ति-होम कराकर, गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा जल को प्रथम प्रवेश कराकर, गायों को (खाने के लिए) दूध, जल, मधु एवं लाजा देकर, आसन पर स्थित ब्राह्मणों को पहिले जल देकर (जल से हाथ धरे गर्भिणी द्वारा शुलवाकर) अक्षत, पुष्प, नान्दीमुख फल (नान्दीमुख श्राद्ध में हित फल या उसके मुखाकृति के खजूरीदि फल) देकर अभिवादन करके स्वयं आचमन करे एवं स्वस्तिवाचन करावे । तत्पश्चात् पुण्य शब्दों का उच्चारण करते हुए गो एवं ब्राह्मण का अनुसरण करती हुई दक्षिण धर से सूतिकागार में प्रवेश करे (चि० ७) एवं वहीं रहकर प्रसवकाल की प्रतीक्षा करे ।

महर्षि सुश्रुत ने नवम मास की प्रशस्त तिथि में सूतिकागार में प्रवेश करने का निर्देश दिया है ।

अथाङ्गसंश्रकार ने लिखा है कि अनुकूल नक्षत्रों में माङ्गलिक शब्दों के साथ गो, ब्राह्मण तथा वृद्ध जनों को नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करके (सूतिकागार में गर्भिणी) प्रवेश करे तथा प्रसूता से स्नेह रखने वाली, आलस्य न करने वाली, क्लेश सहिष्णु अनेकों स्त्रियों के साथ मंगलकर्मों में लगी हुई, अनुलोम करने वाले आहार विहार के प्रयोग से वात, मूत्र एवं पुरीष का अनुलोमन करती हुई प्रसव-काल की प्रतीक्षा करे । मत-मूत्र के तनिक भी विषय होने पर फलवर्ति का प्रयोग करे । अथाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि पुण्य दिन में (गर्भिणी सूतिकागार में) प्रवेश करके बहुप्रसूता स्त्रियों के साथ रहती हुई प्रसव की प्रतीक्षा करे । टीकाकार अरुणदत्त ने 'सूतिकापरिवारिता' शब्द की व्याख्या अनेकों बार की प्रसवानुभूत तथा तत्कालीन व्यवहार में कुशल स्त्री किया है ।

१. सूतिकापरिवारिता-अनेकबारप्रसवानुभूतकालीनव्यवहारकुशलाभिः स्त्रीभिः परिवारिता ॥

(अ० ह० शा० १/७४ की अरुणदत्त टीका)

After beginning of ninth month, on some auspicious day, when moon situated in highest place has association of other beneficial planets, then during *maitra* period pacifying oblation should be offered. Now the cows, *brāhmanas* along with fire and water should be made to enter the ward. The pregnant woman should offer ghee, water, honey and parched paddy to the cows, should wash hands and feet of seated *brāhmanas*, offer them washed rice, flowers and *nāndīmukha* fruit (the fruits used in *nāndīmukha* rites or *khurjira* etc. fruits) and reverential salutation, then she should sip the water and take blessings for welfare. Now the pregnant woman should enter the labour ward by keeping her right foot first and following cows and *brāhmanas* reciting holy words (fig. 7). She should stay there and wait for onset of labour.

Vāgbhata I says that the pregnant woman should enter labour ward during favourable *nakṣatras*, having enchantation of auspicious words, after reverential salutation to cow, *brāhmanas* and elders, be in constant association of women having qualities described earlier. She should remain busy in auspicious virtues and use such dietetics which facilitate proper excretion of flatus, urine and feces. In cases of constipation or retention of urine *phalavarī* should be used.

Śiṣṭuta and Vāgbhata II have given similar but very short description.

विमर्श (Comments)

महर्षि वाग्भट ने सूतिकागार में प्रवेश का कोई निश्चित काल नहीं बताया उन्होंने नवम मास के पूर्व ही सूतिकागार निर्माण की व्यवस्था बताई है जिससे स्पष्ट होता है कि नवम मास के आने पर उसमें स्त्री का प्रवेश कराया जाय । महर्षि चरक ने स्त्री के प्रवेश के पूर्व गो एवं ब्राह्मण के प्रवेश का विधान दिया है जो संभवतः उस काल में प्रचलित सामाजिक संस्कारों के कारण हो । यह भी संभव है कि पूर्व ही निर्मित सूतिकागार में उसके सामान्य जनपद से दूर होने के कारण कोई अवांछित वायु या जीव प्रविष्ट कर गया हो अतः गर्भिणी का प्रथम प्रवेश निषिद्ध किया गया तथा ब्राह्मण एवं गो को आगे प्रवेश कराके अनुगमन कराना ही सुरक्षित समझा गया हो ।

सूतिकागार में निवास के दो लाभ हो सकते हैं (१) स्त्री का सामान्य जन-सम्पर्क से दूर रहने के कारण किसी भी औपसर्गिक व्याधि के उपसर्ग से सुरक्षित रहना ।

(२) मानसिक रूप से प्रसव-वेदना सहन करने के लिए तैयार होना, क्योंकि यह प्रमाणित तथ्य है कि स्त्री की मानसिक अवस्था का प्रसव-वेदनाओं में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ।

Though Vāgbhata has not mentioned specific period for entry in labour ward, however, he has also accepted its construction before ninth month, others have clearly mentioned stay in labour ward from ninth month of pregnancy. Entry of cow and *brāhmanas* described by Caraka might have been given due to social customs prevailing at that time. The labour ward was constructed at a distant place from normal village / city where-in likelihood of entry of some harmful or unwanted animals or gases can not be ruled out, these can injure the pregnant woman. Initial entry of cow and *brāhmanas* will avoid this risk.

Stay in labour ward may prevent the contact of infections since the pregnant woman will be segregated, besides it may also prepare woman psychologically to withstand the labour pains.

प्रसव के समय गर्भाशयान्तर गर्भ की स्थिति (Intrauterine situation of the fetus during labour)

स चपौस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिमारतयोगात् पवित्रत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्पयपथेन, एषा प्रकृतिः, विकृतिः पुनर्तोऽप्यथा । परं ततः स्वतन्त्रवृत्तिर्भवति ॥ (च० सं० शा० ६/२४)

स योनिं शिरसा याति स्वभावात् प्रसवं प्रति । (सु० सं० शा० ५/४५)

एवं जटारस्थो गर्भो जन्मकाले तु प्रसूतिमारतयोगात्पवित्रत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्पयपथेन च्युता मातृहृदयात् । एषा प्रकृतिः । विकृतिरतोऽप्यथा ॥ (अ० सं० शा० २/३५)

वह (गर्भ) जन्मकाल उपस्थित होने पर प्रसूति-मारत के योग से घूमकर नीचे की ओर या आगे की ओर^१ शिर वाला होकर अपत्य पथ से निकलता है यह प्रकृति इससे भिन्न विकृति है । प्रसव के पश्चात् वह गर्भ स्वतंत्र-वृत्ति हो जाता है ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि वह (गर्भ) प्रसव के प्रति (समय में) स्वभाव से ही शिर के द्वारा योनि (प्रजनन-पथ) की ओर चलता है । टीकाकार डल्हण ने इस स्वभाव के लिए पूर्वकर्मों को कारण माना है^२ ।

महर्षि वाग्भट ने भी लिखा है कि उदरस्थ गर्भ जन्मकाल में प्रसूति-मारत के योग से घूमकर नीचे की ओर शिर वाला होकर निकलता है । तत्पश्चात् मातृ-हृदय के च्युत होकर अपना बाहर निकलती है । यह प्रकृति एवं अन्य विकृति है । टीकाकार इन्द्र ने उदर में पृष्ठाभिमुख स्थित गर्भ का घूमकर नाभि की ओर अभिमुख होकर नीचे की ओर शिर करके निकलना लिखा है^३ ।

महर्षि भेल ने लिखा है कि जो अंग आगे होता है वह पहिले उत्तरज होता है, पुनर्वसु आश्रय का मत है कि गुस्तर होने से शिर पहिले उत्तरज होता है^४ ।

At the onset of labour the head of the fetus gets turned and comes forward due to action of *prasaūti-mārta* and then is expelled through vaginal passage; this is normalcy, other situations are abnormal. For this natural phenomena deeds of previous life are held responsible by Dahha. After delivery of fetus placenta getting detached from maternal heart comes out. After delivery the fetus becomes independent for its nourishment. Indu says that fetus situated facing back of the mother gets turned and then facing umbilicus and keeping head at the lowest is delivered. Bheha says that fetal part positioned in the front (at the pelvic brim) delivers first. Punarvasu Atreya opines that head being heaviest comes first.

विमर्श (Comments)

महर्षि चरक ने गर्भांतरस्थ गर्भ की ऊर्ध्व शिर-स्थिति का स्पष्टतया वर्णन किया है सुश्रुत एवं वाग्भट ने पृष्ठाभिमुख तथा संकुचितान्त्र कह कर शिर की स्थिति का वर्णन नहीं दिया^५, परन्तु सभी आचार्यों ने प्रसव के समय शिर का ही सामान्य

१. पवित्रत्यावाक्शिरा-पाठभेद ।
२.स्वभावात् पूर्वकर्मपेक्षया ॥ (सु० सं० शा० ५/४५ की डल्ह० टीका)
३.जटारस्थो गर्भः प्रसूतिवशात् पृष्ठाभिमुखत्वात् पवित्रत्य नाभ्याभिमुखो भूत्वावाक्शिरा निष्क्रामति, अवाक्शिरा अशेषमुखः ॥ (अ० सं० शा० २/३५ की इन्द्र टीका)
४. तस्य ता(य)दुर्ज्ञातं तत् प्रथमं प्रतिपद्यते । तस्मात्तस्य शिरः प्रथमं, पुनर्वसुश्रयः प्रतिपद्यते, तस्य गुस्तरं भवतीति ॥ (भे० सं० शा० ४/३५)
५. च० सं० शा० ६/२३; सु० सं० शा० ५/४५; अ० सं० शा० २/३१ (पृष्ठ १८८-१८९)

रूप से पहिले निकलना लिखा है । शिर नीचे की ओर प्रसव-काल में परिवर्तित न हो अधिकशः गर्भावरस्था के अंतिम त्रैमास में ही परिवर्तित हो जाता है । यद्यपि प्रसव के कुछ ही काल पूर्व भी कतिपय स्थितियों में गर्भ स्थिति का परिवर्तन होता है पर यह सामान्य नियम नहीं माना जा सकता । चूँकि अधिकांश स्थितियों में गर्भावरस्था के समय-मास तक गर्भ की स्थिति निश्चित नहीं होती परन्तु प्रसव के समय लगभग ९५ प्रतिशत स्थितियों में शीर्षोर्ध्व ही होता है सम्भवतः इसी कारण से आचार्यों ने प्रसव-काल के परिवर्तन का वर्णन दिया नो ।

पवित्रत्य शब्द से प्रसववस्था के समय होने वाले शिर के अन्तर्गतन (इन्टरनेल रोटेशन) का ग्रहण कर सकते हैं यहाँ पर शिर शब्द से शरीर के उपाङ्ग शिर का सर्वोच्च भाग (उपशीर्ष या वेंटेक्स) ग्रहण करना होगा क्योंकि मूढगर्भ में मुखोदय आदि का वर्णन पृथक् दिया गया है अर्थात् प्रसव के समय गर्भ के ऊर्ध्व भाग शिर का अन्तर्गतन होकर उसका सर्वोच्च भाग शिर (उपशीर्ष या वेंटेक्स) सामने की ओर आकर सामान्य प्रसव होता है । यह तथ्य गर्भ के परिवर्तित होने के बाद उत्तरज लक्षणों के देखने से पुष्ट हो जाता है ।

सामान्यतया गर्भ माता की पीठ की ओर मुख (पृष्ठाभिमुख) करके प्रसवित होता है अतः टीकाकार इन्द्र की 'नाभ्याभिमुख' व्याख्या उचित प्रतीत नहीं होती; क्योंकि गर्भ का मुख माता की नाभि की ओर हो जाने पर स्वभावतः गर्भ का पृष्ठ माता के मेरुदण्ड पर आ जाएगा एवं इस स्थिति में प्रसव नाण्य (समस्त शीर्षोर्ध्व का ८ प्र० श०) ही होता है । यदि यहाँ पर 'नाभ्याभिमुख' का अर्थ 'गर्भ की रक्त की नाभि की ओर' करें तो आधुनिक ज्ञान पर आधारित वर्णन से सामंजस्य हो सकता है क्योंकि गर्भ का शिर अत्यधिक झुक जाने के कारण उसका मुख स्वयं की नाभि की ओर हो जाता है ।

वायु के भेदों के वर्णन में कहाँ भी प्रसूति-मारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ । अशेषभाग के बहिर्मुख स्रोतसों द्वारा मल, मूत्र, आर्तव एवं गर्भ आदि का निष्काशन कार्य अपना वायु का है^६ । प्रसव सम्बन्धी विशिष्ट कार्य करने वाली अपना वायु को ही प्रसूति-मारत शब्द से आचार्यों ने सम्बन्धित किया है ।

मूढगर्भान्तर्गत आचार्यों ने गर्भ का शिर, अंस एवं जघन तीन प्रकार से योनि पथ में सङ्ग माना है^७, अर्थात् गर्भ श्रोणि-गुहा में इन्होंने तीन स्थितियों से अवर्तित होता है । इन तीनों स्थितियों को क्रमशः शिर, तिर्यक् या अनुप्रस्थ एवं रिक्क स्थिति का द्योतक मान सकते हैं ।

In normal intrauterine situation of fetus Caraka has described upward position of head, while others not specifying position of head have accepted universally flexed attitude. However, all of them agree that head position / delivery is normal. Head usually attains downward situation in the last trimester of pregnancy, however, in exceptional cases it does rotate just prior to labour. Since more than 95% deliveries occur in head position, thus all the classics have mentioned this normal situation.

With the word "parivṛta" or rotation actually internal rotation occurring during labour should be considered. In this context head refers to vertex, because face, brow etc. have been mentioned under obstructed labour, thus the description should be considered as forward position of vertex obtained by internal rotation; which is corroborated by the clinical feature after parivartana of garbh.

१. अ)। अपान। सुजलवर्तवर्णनौ च। (च० सं० वि० २८/१०, ११)
- आ)अपानः काले कर्षति चापधः। समीरणः शकुन्मूत्रं शुक्रगर्भावर्तवर्तनं च ॥ (सु० सं० वि० १/१९)
- इ) अपानो.....विण्मूत्रशुक्रवर्तवर्तनं निष्क्रमणादिक्रियः ॥ (अ० सं० सू० २०/४)
- ई) अपानो। शुक्रवर्तवर्तनं मूत्रगर्भावर्तनं निष्क्रमणादिक्रियः । (अ० ह० सू० १२/९)
२. सु० सं० वि० १५/४ एवं अ० सं० शा० ४/३४ (मूढगर्भ के विशिष्ट लक्षणों में वर्णित)

In normal situation fetus faces back of the mother. Fetus facing umbilicus of the mother would mean occipito posterior position which is only 8.0% of all vertex presentations, not a normal phenomenon. Thus here the description of Indu should be considered as fetus facing its own umbilicus due to exaggerated flexion.

In the classifications of vāyu word "prasthi-mānava" has not appeared. All the movements of lower abdominal viscera are controlled by *apāna vāyu*. Probably *apāna vāyu* controlling specifically the process of expulsion of fetus has been referred as "prasthi-mānava".

Under obstructed labour fixation of fetus in maternal passage in said to occur in three ways i. e. head, shoulder and thighs or hips, this indicates that fetal ovoid descends in maternal passage in these three ways i. e. both the types of longitudinal lie (vertex and breech) and transverse or oblique lie. In other words this may be considered as reference for lie of the fetus.

प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण (Clinical features of different stages of labour)

अ) प्रजायिनी के लक्षण (Clinical features of Prājāyini)

जाते हि शिथिले कुक्षौ मुक्ते हृदयबन्धने । सशूल जघने नारी नेया सा तु प्रजायिनी ॥
(सु० सं० शा० १०/६)

कुक्षि में शिथिलता, हृदय-बंधन-मुक्ति तथा जघन (प्रदेश) में वेदना होने पर (स्त्री को) प्रजायिनी समझना चाहिए ।
आचार्य भवामिश्र ने उपर्युक्त लक्षण ही प्रसवोत्सुका स्त्री के वर्णित किये हैं ।

Woman having laxity of *kukṣi* (abdomen/flanks), release of bond of *hṛdaya* and pain in thighs should be known as *prājāyini*. Bhāvaprakāśa has termed this stage as 'prastavotsukā' (eager to deliver).

आ) आसन्न प्रसवा या उपस्थित प्रसवा के लक्षण (Clinical features of āsanna prasavā or upasthita prasavā)

तस्यास्तु खल्विमानि लिङ्गानि प्रजनकालमभिपतो भवन्ति; तदथा-कलमो गात्राणां, नत्नान्नानस्य, अश्लोः शैथिल्यं, विमुक्तबन्धनत्वमिवक्ष्यसः, कुक्षेयवत्संनम, अधोगुरुत्वं, वक्षणावस्थिकटीकुक्षिपाश्वर्यपृष्ठनिस्तोदः, योनेः प्रसवपणम्, अनन्नाभिलाषश्चेति, ततोऽनन्तरमावीनां प्रादुर्भावः, प्रसेकश्च गर्भोदकस्य ॥ (च० सं० शा० ८/३६)

तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीपृष्ठं प्रति समन्ताद्देहना भवत्यभीष्टां पुरीषप्रवृत्तिर्नृनं प्रसिच्यते योनिमुखात् श्लेष्मा च ॥ (सु० सं० शा० १०/७)

तत्रासन्नप्रसवायाः कलमो नत्नानिर्मुक्तबन्धने इवाक्षिणी निष्ठोविकामप्रपुरीषबाहुल्यं शिथिलकुक्षिताः-धोगुरुत्वमभिलाषो वेदनोदरहृदयकटीवस्तिवङ्क्षणेषु तोदभेदशूलसुरणप्रसवणानि च योन्या भवन्ति । तदनन्तरमावीनां प्रादुर्भावो गर्भोदकप्रवाहश्च ॥ (अ० सं० शा० ३/१७)

अधः श्वः प्रसवे नत्नानिः कुक्ष्यक्षिप्रलथावत्तमः ॥ ७४॥

अधोगुरुत्वमस्तिवः प्रसेको बहुमूत्रता । वेदनोदरकटीपृष्ठहृदयस्तिवङ्क्षणे ॥ ७५॥

१. जाते हि नारी विज्ञेया प्रसवोत्सुका ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३४३; सु० सं० सदृश)

योनिभेदरुजातोदसुरणप्रसवणानि च । आवीनामनुजन्मास्ततो गर्भोदकस्युतिः ॥ ७६॥
(अ० ह० शा० १/७४ से ७६)

अथ हीमानि रूपाणि गर्भेणया उपलक्ष्येते । यानि दृष्ट्वा विज्ञानीयादबालजन्मा (म) द्युपक्रमेत् (मम) ॥
मुखल्लानिः कलमोऽङ्गानामक्षिबन्धनमुक्तता । कुक्षेश्च स्यादवत्संस्त्वधोभागस्य गौरवम् ॥

पृष्ठपाश्वकटीवस्तिवक्षणां चातिवृद्धिः ।

योनिप्रसवणौदार्यं (शु० पा० प्रसवणौदार्ये) भक्तद्देहावतिवत्तमः ॥ (का० सं० शा० ५/२१ से २३)

प्रजनन काल के समीप आ जाने पर उसमें निम्न लक्षण होते हैं जैसे-गात्रों में कलम (शरीर में धकावट), मुख की रत्नानि (मुख की कान्ति का कम हो जाना या उदासी), आँखों का शैथिल्य, वक्ष के बंधनों से विमुक्तता की प्रतीति, कुक्षि का अवत्संनम, अधोभाग की गुराग्रा वक्षणा, बस्ति, कटि, कुक्षि, पाश्वर्य एवं पृष्ठ में वेदना, योनि से साव तथा अन्न की आकांक्षा न होना । तत्पश्चात् आवी (प्रसव वेदनाओं) का प्रादुर्भाव तथा गर्भोदक का प्रसेक होता है ।

महर्षि सूत्र ने लिखा है कि उपस्थित प्रसवा (स्त्री) के कटि एवं पृष्ठ में तथा उसके चारों ओर बार बार फीड़ा होती है, मल की प्रवृत्ति, मूत्र का साव एवं योनिमुख से श्लेष्मा का साव होता है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि आसन्न प्रसवा को कलम, नत्नानि, आँखों के बन्धनों से मुक्ति हो जाने सदृश प्रतीति (आँखें बाहर को निकली सी आना), निष्ठोवन (बार बार झुकना), मूत्र एवं पुरीष का बाहुल्य (बार बार प्रवृत्ति), कुक्षि की शिथिलता, अधोभाग में गुरुता, अन्न की अभिलाषा न होना, उदर, हृदय (उदर का ऊर्ध्व भाग), बस्ति, कटि एवं वक्षण में वेदना, योनि में तोद (चुने की वेदना), भेद (फटने सदृश वेदना), शूल, सुरण तथा योनि से साव होता है; तत्पश्चात् आवी का प्रारम्भ एवं गर्भोदक का प्रवाह होता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि आजकाल में प्रसव होने की स्थिति में नत्नानि, कुक्षि एवं अक्षि (आँखों) की शिथिलता, कलम, अधोभाग में गुरुता, अर्त्तव, प्रसेक (मुख प्रसेक), बहुमूत्रता; उर, उदर, कटि, पृष्ठ, हृदय, बस्ति तथा वक्षण में वेदना, योनि में तोद, भेद, शूल, सुरण तथा योनिस्त्राव होता है; तत्पश्चात् आविषों का प्रादुर्भाव एवं गर्भोदक का साव होता है । टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है कि गर्भ के अभिमुख हो जाने, आवि-प्रदुर्भाव तथा गर्भोदक-स्युति हो जाने से स्त्री उपस्थित प्रसवा है, यह समझना चाहिए ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि गर्भिणी के निम्न लक्षणों को देखकर यह समझ ले कि अब बालक के जन्म का उपक्रम है (अर्थात् प्रसव होने वाला है) । मुख की नत्नानि, अङ्गों में कलम, आँखों के बंधन की मुक्तता, कुक्षि का अवत्संनम, अधोभाग की गुरुता, पृष्ठ, पाश्वर्य, कटि, बस्ति तथा वक्षणा प्रदेश में अत्यधिक तोद, योनि से साव एवं उसका विस्फार, भोजन से अरत्ति, अर्त्तव तथा धकावट आदि लक्षण होते हैं ।

आचार्य भवामिश्र ने लिखा है कि आसन्न-प्रसवा को कटि एवं पृष्ठ में व्यथा, बार-बार मल एवं मूत्र की प्रवृत्ति होती है ।

When the woman is likely to deliver shortly, she feels exhausted or fatigued, her face becomes languid, eyes (eyes lids) become lax (droopy). She feels as if bonds of chest are released, *kukṣi* (uterus) comes down, lower abdomen becomes heavy. She feels pain in groins, urinary bladder and sacral region, flanks and back. Discharges per vagina and anorexia appear. This is followed by appearance of *āvī* (labour pains) and excretion of *garbhodaka* (liquor amni).

१. उपस्थित गर्भा अभिमुखीभूतगर्भाविषानोदकसावादिना ज्ञाता ॥ (अ० ह० शा० १/७६ की अरुण० टीका)

२. आसन्नप्रसवायास्तु कटीपृष्ठं तु सव्यधम् । भवेन्मूद्रः प्रवृत्तिश्च मूत्रस्य च मलस्य च ॥ (पा० प्र० पूर्व० ३/३४३)

Sūśruta and Bhāvaprakāśa say that during this period there appears recurrent severe pain around back and sacrum. Excretion of feces and urine with increased frequency and mucoid discharges per vaginam appear.

Vāgbhaṭas corroborating Caraka add that she has tendency to spit repeatedly, frequency of micturition and defecation increases. Pricking or tearing type of pain, and quivering in vagina along with discharges occur.

Kāśyapa has added dilatation of yoni (cervix and vagina) as a sign.

(इ) गर्भ के परिवर्तित या अवाक् अर्थात् नीचे की ओर प्रवृत्त होने पर लक्षण (Clinical features) *after parivartana of garbha or after its descent*

स यदा जानीयाद्विमुख हृदयमुद्रमस्यास्त्वाविशति, वस्तिशितोऽवगृह्णाति, त्वयन्त्येनामाव्यः, परिवर्तितोऽधो गर्भ इति; (च० सं० शा० ८/३९)

एवमावाक् परिवर्तिते गर्भः । तस्य लक्षणम् । विमुख्य हृदयमुद्रमाविशति वस्तिशितोऽवगृह्णाति । त्वयन्त्येनामाव्यः । (अ० सं० शा० ३/२०, २१)

गर्भः प्रयात्यवागेवं, तस्मिन् हृदिमोक्षतः ॥ ७९ ॥

आविश्य जठरं गर्भो बस्तेरुपरि तिष्ठति । आत्वोऽभिभवयन्त्येनां ॥ ८० ॥ (अ० सं० शा० १)

यदा गर्भोर्दकं योनीं स्पृशति संप्रवर्तते । कातेन चोदितो गर्भो विमुख्य हृदयोदरम् ॥

वस्तिशीर्षमधोभागमावगृह्णाति जन्मति । त्वानिष्ठ जायतेऽत्यर्थं योऽनुसीडनभेदनम् ॥

इत्येते कारणीविद्यादागर्भस्य परिवर्तनम् ॥ (का० सं० शा० ५/४४ से ४६)

वह (चिकित्सक) जब यह जान ले कि वह (गर्भ) हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश कर रहा है, वस्तिशिर को पकड़ता है; आवां बहुत शीघ्र आने लगी है एवं वह गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो गया है (तब कुछ ही देर में प्रसवित होने वाला है) ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि गर्भ के अवाक् परिवर्तित होने या नीचे आने पर ये लक्षण होते हैं—(वह गर्भ) हृदय को छोड़कर उदर में प्रविष्ट होता है, वस्तिशिर को पकड़ता है एवं आवां जल्दी जल्दी आने लगती है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि गर्भ के अवाक् हो जाने पर निम्न लक्षण होते हैं—हृदय के बंधनों की मुक्ति हो, (वह गर्भ) उदर में प्रविष्ट हो वस्ति के ऊपर स्थित होता है । आवां इसमें बहुत ही शीघ्र आने लगती है ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि जब शूल के साथ गर्भोर्दक योनि से प्रवर्तित होने लगता है एवं काल से प्रेरित हुआ गर्भ जन्म के लिए (उत्पन्न होने के लिए) हृदय को छोड़कर उदर, वस्तिशीर्ष तथा अधोभाग का अवग्रहण करता है तब योनि में अत्यधिक उत्पीड़न (दबाव का अनुभव) तथा भेदन (फटने सदृश वेदना) होता है, इन कारणों (लक्षणों) से जाने कि गर्भ का परिवर्तन हो गया है ।

महर्षि भेल ने प्रसववस्था का कोई विशिष्ट नाम न देकर केवल इतना ही लिखा है कि वह स्त्री जब जान जाये कि मेरी कुक्षि अवग्रह है या नीचे खिसक गई है, हृदय विमुक्त हो गया है तथा योनि से स्राव होने लगा है तो प्रसव होने वाला है यह समझना चाहिए ।

When the fetus descends further or is going to be expelled (*parivartana*) it leaves the *hydya* (cardiac region), enters or descends in lower abdomen, catches or stays at the region

१. यो० सं० शा० ८/८ (पृष्ठ ४४३)

of neck of bladder and the frequency and duration of labour pains increases. Kāśyapa had added languor, feeling of severe compression and tearing pain in vagina. Bheḥa has included discharges per vaginam in clinical features.

विमर्श (Comments)

लक्षणों में सभी आचार्यों ने वक्ष या हृदय के बन्धनों की विमुक्ति शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य गर्भ के नीचे श्रोणिगुहा में प्रविष्ट हो जाने के कारण वक्ष के भाग में दबाव की कमी या आराम की अनुभूति है । अन्य सभी लक्षण क्रमशः गर्भ के नीचे योनिपथ में आने के कारण मूत्राशय एवं मलाशय में उत्पन्न भ्रात-जन्म तथा प्रसव-वेदनाओं के कारण उत्पन्न श्कावट के हैं । महर्षि चरक एवं वाग्भट ने 'गर्भ के परिवर्तित' होने का वर्णन दिया है जिसका स्पष्टीकरण पृष्ठ ४३४ से ४३६ में दिया जा चुका है ।

महर्षि चरक एवं वाग्भट ने प्रसव के लक्षणों को दो अवस्थाओं से विभक्त किया है । प्रजननकालाभिमत स्त्री या "आसन्न प्रसवा" के लक्षण एवं "गर्भ के परिवर्तित हो जाने पर लक्षण" तथा महर्षि सुश्रुत ने 'प्रजायिनी' एवं 'उपस्थितप्रसवा' के लक्षणों का उल्लेख किया है । लक्षणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि सुश्रुत-वर्णित प्रजायिनी या भावमिश्र उल्लिखित प्रसवोत्सुका प्रसव की प्रथम अवस्था के प्रारम्भ के लक्षणों या प्रसव के एक या दो दिन पूर्व के लक्षणों का एवं उपस्थित प्रसवा के लक्षण प्रसव की प्रथमावस्था के अंतिम अवस्था द्वितीयावस्था के प्रारम्भ के लक्षणों का वर्णन है । महर्षि सुश्रुत सदृश लब्ध-प्रतिष्ठ शल्यचिद्विद ने यहाँ पर गर्भोर्दक का वर्णन क्यों नहीं दिया कहना कठिन है । महर्षि चरक एवं वाग्भट वर्णित 'प्रजननकालाभिमत' या "आसन्नप्रसवा" के लक्षण प्रसव की प्रथमावस्था के लक्षणों का वर्णन है । गर्भ के परिवर्तित या अवाक् होने के लक्षण द्वितीयावस्था में शिशुजन्म के कुछ क्षण पूर्व के लक्षण हैं । यद्यपि वर्णन में आगे गर्भ के प्रसव तथा अपरा-पतन का स्पष्ट निर्देश मिलता है परन्तु उनका प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में वर्णन नहीं दिया गया । गर्भ के निर्माण के पश्चात् कुछ क्षणों में ही अपरा का निर्माण स्वाभाविक है ऐसा महर्षि वाग्भट ने स्पष्ट लिखा है । महर्षि काश्यप ने अपरा-निर्माण के पूर्व तक की स्थिति को प्रसूता के अन्तर्गत नहीं रखा अर्थात् प्रसव अपरा-निर्माण के पश्चात् ही पूर्ण होता है ।

गर्भ निष्क्रमणार्थ होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ निम्नांकित है :-

१. अवसंसन-हृदय बन्धन-विमुक्ति, कुक्षि का अवसंसन, अधोभ्रंश, वस्ति-शिर-अवग्रहण आदि (पृष्ठ ४३६ से ४३८)

२. सङ्कोच-संकुचितान्नावस्था (पृष्ठ १८८, १८९), गर्भ का स्वयं की नाभि की ओर उन्मुख होना (पृष्ठ ४३४) एवं गर्भ शिर का अवाक् होना ।

३. अन्तर्गर्भ-गर्भ शिर का अवाक् होकर परिवर्तित होना (पृष्ठ ४३४, ४३५ एवं ४३८) ।

Release of bonds of *hydya* or *vaksā* has been mentioned by all the writers. Actually there are no structural attachments between chest/heart and uterus/fetus. It appears that feeling of relief from compression of chest due to descend of fetus in the pelvic cavity has been mentioned as release of bonds. Increase in frequency of defecation and micturition and pain along with compression etc. are the clinical features of further descend of fetus. Caraka, Vāgbhaṭa and Kāśyapa have described '*parivartana*' of fetus which has already been dis-

१. अ० सं० शा० २/३५ (पृष्ठ ४३४)

२. सूतायाश्चापि तत्र स्यादपरा चेन्न निर्गता । प्रसूतापि न सूता स्त्री भवत्येवं गते सति ॥ (का० सं० छि० ११/६)

cussed earlier, here in this context it refers to internal rotation occurring in pelvis after descend and exaggerated flexion. Internal rotation (*antarāvartana*) of vertex fits better in the word '*parivartana*'.

Caraka and Vāgbhata have described clinical features under two headings i.e. *prajānankālābhīnata* or *āsanaprasavā* woman and after '*parivartana* of *garbha*'. Suśruta has mentioned '*prajāyini*' and '*upasthiaprasavā*' as two stages. Bhāvaprakāśa has used word '*prasavotsukā*' instead of *prajāyini*. The omission of reference about liquor amni by Suśruta is difficult to explain.

On the basis of clinical features these different stages of labour can be explained in following way :—

So. No.	Name given in classics	Author	Probable stage of labour
1A	<i>Prajāyini</i> or <i>prasavotsukā</i>	Suśruta Bhāvaprakāśa	One or two days before the labour or just beginning of first stage.
1B	<i>Prajānankālābhīnata</i> or <i>āsanaprasavā</i> or no specific term	Caraka Vāgbhata Kāśyapa	First stage of labour.
2A	<i>Upasthiaprasavā</i>	Suśruta and Bhāvaprakāśa	End of first stage or beginning of second stage.
2B	<i>Parivartita garbha</i>	Caraka, Vāgbhata and Kāśyapa	Second stage of labour.
3	Expulsion of Placenta.	All	Third stage of labour.

Different movements of mechanism of labour have been described in following way.

i. Descend—Release of bonds of heart, descend of *kukūṣi*, catching up of bladder-neck etc.

ii. Flexion—Universally flexed attitude; facing its own umbilicus (exaggerated flexion), downwards displacement of vertex etc.

iii. Internal rotation—*Parivartana of śira*.

Though expulsion of placenta has not been given any specific name, however, its expulsion following labour has been described by all the authors. Vāgbhata has clearly mentioned that expulsion of placenta after the fetus is a normalcy. Kāśyapa says that a woman without expulsion of placenta is not a *śāitkā* (puerperal).

आवी का प्रसव में प्रभाव (*Effect of āvis or accouchement force on labour*)

आय्यावृत्ते स्त्रिया गर्भे विवृते चापरामुखे । ग्राहीषु वर्तमानसु सा विविवर्तते (सावि वर्तते शुष्णः) गर्भिणी न तीक्ष्णं ग्राहिशूलेषु क्षिप्रं नारी प्रजायते । विलिम्बिताभिवातीभिर्ममः क्लेशयते स्त्रियम् ॥

(का० सं० शा० ५/३०, ३१)

ग्राही शब्द का प्रयोग किसी अन्य संहिता में प्रसव वेदनाओं के लिए नहीं हुआ। दुर्भा प्रयोग में महर्षि कारण ने स्वयं ही ग्राहिशूल शब्द का प्रयोग किया है। 'ग्राहि' का शाब्दिक अर्थ है 'पकड़ना' अतः यहाँ पर 'ग्राहिशूल' अर्थात् 'पकड़ने या भिचने सदृश शूल' यह अर्थ उचित होगा। 'सा विवर्तते' के स्थान में 'सावि वर्तते' पाठ व्याकरण-दृष्ट्या अधिक युक्तिसंगत है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर रत्नको के निम्न अर्थ करना होगा।

स्त्री के गर्भ के स्वस्थान में सामान्य रूप से स्थित होने, अपरामुख (गर्भाशयमुख) के विरुद्ध होने तथा आवी के साथ ही ग्राहिशूल (आवी अर्थात् गर्भाशय-पेशी के संकोच-जन्य प्रसव वेदनाएँ एवं ग्राहिशूल अर्थात् उदरादि की मांसपेशी-संकोच-जन्य शूल) उपस्थित होने पर वह गर्भिणी (प्रसव के लिए) उद्यत होती है।

ग्राहिशूल तीक्ष्ण होने पर भी स्त्री को शीघ्र प्रसव नहीं होता अर्थात् जब तक आवी (गर्भाशय संकोच-जन्य शूल) नहीं होगी किन्तु भी तीव्र ग्राहिशूल (उदरपेशी संकोच-जन्य शूल) हो प्रसव नहीं होगा (इसी भाँति) आवी के देर देर से आने पर भी स्त्री के गर्भ को क्लेश होता है (विलिम्बित आवी के कारण विलिम्बित प्रसव होने पर गर्भ को गर्भाशयान्तर खसावरोध होने से कष्ट हो सकता है)।

The woman having normally situated fetus, dilatation of *aparāmanukha* (cervix uteri) and presence of *āvi* (normal uterine contractions during labour i.e. contraction, relaxation and retraction) alongwith *grāhishūla* (seizing like pain arising due to contraction of abdominal wall etc. i.e. secondary force of labour) is very much ready to deliver the fetus.

In spite of existence of very severe *grāhishūla* the woman does not get early delivery (strongest *grāhishūla* can not effect labour, presence of *āvis* is must.) If the *āvis* are delayed the fetus is troubled (weak uterine contraction can delay the labour resulting in asphyxia to the fetus).

पुत्र या पुत्री के अनुसार प्रसव-पूर्व साव (*Colour of 'show' according to sex of the fetus*)

तन्त्रीवर्णोऽल्पशः सावः पिच्छिलः पुत्रजन्मनि । किशुकोदकसंकाशः पुत्रिकाजन्म शंसति ॥

(का० सं० शा० ५/२८)

पुत्र के जन्म में स्त्री को गिलोय (के स्वरस) के वर्ण का, अल्प एवं पिच्छिल साव होता है तथा पुत्री के जन्म में किशुकोदक (पलाश के पुष्प को धोने से निकला जल या गरहा लाल रंग) के समान साव होता है।

(गर्भ-लिङ्ग के आधार पर प्रसव-पूर्व-साव-वर्णन अनुसंधान का विषय है निश्चित स्वीकरण कठिन है)।

If the woman is going to deliver a male child, she will have scanty, unctuous show resembling the colour of *guānci* (very light yellowish pink), however, if she is to deliver a female child, her show would resemble the colour of water obtained by washing the flowers of *palāśa* (dark red).

प्रसव के समय परिचर्या (Management of labour)

अ) आसन्नप्रसवा-परिचर्या (Management of asannaprasava or during first stage of labour)

आवीप्रदुर्भावे तु भूतौ शयनं विदध्यान्मृदास्तरणोपगमम् । तदध्यासीत सा । तां ततः समन्ततः परिचर्यां

याथोक्तगुणाः स्त्रियः पर्युपासीरञ्चाश्वासयन्त्यो वाग्भिग्राहणीयाभिः सान्त्वनीयाभिश्च ॥ (च० सं० शा० ८/३७)

प्रजनविषयमाणां कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनां कुभारपरिवृतां पुत्रामफलहस्तां स्वस्थकामुष्णोदकपरिष्कामधैनां सम्पूतानां यवागूपाकण्ठानां पाययेत् । ततः कृतोपधाने मूर्द्धनि विस्तीर्णौ शयने स्थितामभ्युनमसवस्थीनुत्तानामशङ्कनी-याश्चतस्रः स्त्रियः परिणतवयसः प्रजनकुशलताः कर्तितनखाः परिचर्युरिति ॥ ८८॥ (सु० सं० शा० १०/८)

अधैनमुपस्थितगर्भां कृतकौतुकमङ्गलानां पुत्रामफलहस्तां स्वस्थकामुष्णोदकपरिष्कानां सधृतां यवागूपाययेत् ॥ ९८॥

तथा सुरतावर्धभचर्मप्रच्छदे (शु० पा०-रक्तर्धः=रक्त+ऋध) मूर्द्धनि भूमिशयने शयानामुत्तानामभ्युनमस-विश्वपुष्टामहत्वाससोऽशङ्कनीयाः प्रियदर्शनाः परिणतवयसः प्रजनकुशलताः प्रगल्भाः कृतनखाः स्त्रियः सूतिकां सुनृताभिर्वाणीभिश्चाश्वासयन्त्यः पर्युपासीरन् ॥ ९९॥

अथास्ये दद्यात् कुष्ठैलालाङ्गीववाचव्याचित्रकचिरविल्वचूर्णमुपाधत्तुं मुहुर्मुहुः । तथा भूर्जपत्रशिपिपास-जंरसात्यतमधूमन्तान्ता च । पार्श्वपृष्ठकटीसंविशदेशान्कोषणे तैलेनाप्यन्यानुसुखमस्या मृदनीयात् । एवमवाक् परिवर्तते गर्भः ॥ २०॥ (अ० सं० शा० ३/९८ से २०)

अथोपस्थितगर्भां तां कृतकौतुकमङ्गलानां हस्तस्थपुत्रामफलं स्वस्थकामुष्णान्बुसेवित्वा ॥ ७७॥ पाययेत्सधृतां पेयां तनौ भूशयने स्थिताम् । आभ्युनमसिक्थमुत्तानामभ्युनमसि पुनः पुनः ॥ ७८॥

अथो नाभोर्विपरीत्यात्कारयेन्जम्बवद्वक्रमम् ॥ (अ० ह० शा० १/७७ से ७९)

एतानि दृष्ट्वा रूपाणि कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् प्रविशेयुः स्त्रियो वृद्धाः कुशलाः शस्तधार्तिम् ॥
गर्भिणीं सान्त्वयेयुस्ता हर्षयेयुः प्रियंवदाः । आश्वासयेयुर्धर्मार्थौ चोदयन्तं प्रजापतिम् ॥
लोकान् पुत्रवतीनां च सुखानि विविधानि च । कीर्तयेयुर्पुत्राणां दुःखानि निरयादिषु ॥
अदितिं कश्यपं देवमिन्द्राणीमिन्द्रमाश्विनौ । आयुष्मतां पुत्रवतां मङ्गल्यानां च कीर्तनम् ॥
उपविष्टाऽसकृत्समादिनिर्विण्णारऽप्रपान्तिता । वृद्धस्त्रीद्वयसंपन्ना प्रजायेत् प्रजाधिनी ॥

(का० सं० शा० ५/२४ से २७, ३९)

स्त्रीणां प्रसवकाले तु मांसं.....पेय च । (का० सं० खि० २४/७७)

आवी (प्रसव वेदनाओं के) के प्रादुर्भाव हो जाने पर भूमि में मृदु आसन्न (विस्तार) बिछा दे, उस पर वह स्त्री बैठ जाय तत्पश्चात् उसको (उस प्रजाधिनी स्त्री को) पूर्ववर्णित (सूतिकागार में संप्रहणीय पदार्थों के अन्तर्गत-पृष्ठ ४३९) गुणों वाली प्रजनन-कुशल स्त्रियाँ चारों ओर से घेर कर हृदय को प्रिय लगाने तथा सान्त्वना देने वाले वचनों से आश्वासन देती हुई सेवा करें ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि मंगल एवं स्वस्तिवाचन की हुई, कुमार्तों से घिरी हुई, हाथ में पुत्राम फल (पुष्पिण नाम वाले फल) को ग्रहण की हुई, (तैल से) अभ्यंग तथा उष्णोदक से स्नान की हुई प्रजनविषयमाणा (प्रसूत होने वाली) स्त्री को बलकाक यवागू आकण्ठ (कण्ठ तक या पूरा पेट भर कर) पान कराए । तत्पश्चात् उपधान (तकिया) रखे हुए, बिछे हुए, मृदु विस्तरे पर सविषयों को मोड़ कर उत्तान लेटी हुई (प्रसविनी) स्त्री को शंका न करने योग्य, पूर्ण वयस्क, प्रसव-कार्य में कुशल एवं कर्तित नख वाली चार स्त्रियाँ परिचर्या करें ।

प्रसव-विज्ञानीय

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि कौतुकमंगल-कर्म (कौतुक नामक मंगल-कार्य) की हुई, पुत्राम फल हाथ में ली हुई, (तैल से) अभ्यंग एवं उष्णोदक से स्नान की हुई, उपस्थितागर्भा स्त्री (प्रसव के लिए गर्भ के नीचे आ गई हुई स्त्री या प्रसवोन्मुखी स्त्री) को घृत-युक्त यवागू पिलाए । तत्पश्चात् भूमि में बिछे हुए रक्त वृषभ के चर्म से आच्छादित मृदु विस्तार पर सविश्व एवं पृष्ठ (कटि का नीचे का भाग) मोड़कर, उत्तान शयन की हुई उस सूतिका की अच्छे या बिना फटे कपड़े पहनी हुई, अशंकनीय (जिनकी कार्य कुशलता में शंका न हो), प्रियदर्शना (सुन्दर), पूर्णवयस्क, प्रजननकर्म कुशल, प्रगल्भा, कर्तित नख वाली स्त्रियाँ प्रिय वचनों के द्वारा आश्वासन देती हुई सेवा करें एवं इसे कुष्ठ, एला, लाङ्गली, वचा, चव्य, चित्रक एवं चिरविल्व (एक एक या सभी एकत्रित) के चूर्णों को बार बार सूँघने को दें तथा बीच बीच में भूर्जपत्र, शिपिपा (शीशम के पत्र), सर्जरस आदि के धूम को (सूँघने को) दें । टीकाकार इन्दु ने इस भूर्जपत्रादि को आवी-प्रादुर्भाव आदि के बीच में (अर्थात् दो आधियों के मध्यकाल में) सूँघने का विधान दिया है । पार्श्व, पृष्ठ, कटि तथा सविश्व प्रदेश को कोषण तैल से सुख पूर्वक (धीरे धीरे) अभ्यङ्ग करें । इस प्रकार करने से गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित होता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि कौतुकमंगल कर्म की हुई, हाथ में पुत्राम फल धारण की हुई, अभ्यङ्ग एवं उष्ण जल के स्नान की हुई उपस्थितागर्भा स्त्री को घृत-युक्त पेया पिलाकर भूमि में स्थित मृदु विस्तार पर सविश्व मोड़कर उत्तान शयन कराकर बार-बार अभ्यङ्ग एवं ताभि के नीचे के भाग में मर्दन करे तथा (स्त्री को) बार बार जूम्भण एवं चक्रमण करावाए । टीकाकार अरण्यदत्त ने लिखा है कि गर्भावस्था के विशिष्ट काल में बाहु आदि में बौधे गए रक्षाबन्ध को 'कौतुक' कहा जाता है; पुनः पुनः अभ्यङ्ग वायु-प्रकोप के भय के कारण किया जाता है; इस सभी कर्मों से गर्भ अवाक् हो जाता है अर्थात् ऊपर से खिसक कर नीचे आ जाता है; अष्टाङ्गसंग्रहोक्त औषधियों का तथा आग्नि-पृष्ठों में वर्णित गर्भ के अवाक् लाने के उपायों के अन्तर्गत वर्णित मुसलादि से व्यायाम के निर्देश एवं उसके करने से प्राण-हानि आदि का भी वर्णन दिया है तथा विमर्दनादि क्रिया को गर्भ-निक्रमण पर्यन्त करने का निर्देश दिया है ।

महर्षि कश्यप ने लिखा है कि इन रूपों को (प्रसव होने वाला है ऐसे लक्षणों को) देखकर वृद्ध, कुशल एवं स्नान से शुद्ध हुई स्त्रियाँ ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर प्रवेश (सूतिकागार में) करें । ये प्रिय बोलने वाली स्त्रियाँ धर्म और अर्थ के लिए प्रजापति को प्रेरित करती हुई गर्भिणी को सान्त्वना दें, हर्षित करें, आश्वासन दें तथा संसार में पुत्रवती स्त्री के विविध सुखों तथा निःपुत्री के दुःखों का वर्णन एवं अदिति, कश्यप, देव, इन्द्राणी, इन्द्र, अग्निवीरकुमार तथा अन्य आयुष्मान एवं पुत्रवान् मंगलकारी देवताओं का कीर्तन करें । प्रसव की इच्छा वाली स्त्री को चाहिए कि वह प्रसन्न मन वाली, लज्जा से रहित, वृद्ध स्त्रियों तथा धन से युक्त बैठी हुई बार-बार प्रसव (के प्रयत्न) को करे । अन्यत्र प्रसव-काल में मांसरस प्रयोग हितकारी बताया है ।

महर्षि भेल ने लिखा है कि जिस स्त्री को भविष्य में प्रसव वेदनायें आयेंगी अर्थात् अभी नहीं आई उसे अवहन्तन न करे अर्थात् आघात न पहुँचाये । जब कुक्षि अवपृष्ठ हो जाए, हृदय से गर्भ विमुक्त हो जाय, योनि से स्राव होने लगे तो उपकार करने वाली चार सहस्त्रियाँ प्रतिदिन उसके पास रहें ।

आचार्य भावमिश्र ने भी उपर्युक्त वर्णन सदृश ही अभ्यङ्ग एवं स्नान की हुई स्त्री को यवागू पिला कर मृदु तकिया

१. तथैव पूर्वाह्नान्तमधूमुपाधत्तुं दद्यादिति सम्बन्धः, अन्तरान्ता चेत्यावीप्रदुर्भावमधूमदि प्रसङ्गे ॥

(अ० सं० शा० ३/२० इन्द्र टीका)

२. विशिष्ट काल एवं यो रक्षाबन्धो बध्यते स कौतुक बाध्यः । कौतुकाख्यां मङ्गलं कौतुकमङ्गलम् । तथा

पुनः पनुप्यकाङ्गी वातकोभयार्त् । एवं अत्यधिकतथैवतयाऽनुष्ठितया, गर्भोऽवाक्प्रयति-केश्वरियो गच्छति..... विमर्दनादि क्रिया च गर्भिण्यास्तावत्कारयेत् यावन्नभीष्कमणं न भवति ॥ (अ० ह० शा० १/७७ से ७९ की अरण्य० टीका)

३. अनगत्त गभवेदां चैतां अवहन्तं च (न) कारयेत् । सा यदि जानीयात्पृष्ठे मे कुक्षिः प्रविमुक्तो मे हर्षभः प्रसूता मे योनिरिति । अधैनमुपकारिकरितस्तस्यैवाश्वासो (सऽ) प्रजाविकाः प्रतिदिनमुपातिष्ठेयुः । (धे० सं० शा० ८/८)

से युक्त विस्तर पर आभुग्न सन्निध (दोनों उरुओं को असंकोचित भाव अर्थात् एक दूसरे से अलग अलग रख कर) एवं उत्तान शयन करके, प्रजनन कुशल स्थियों द्वारा अपत्यमार्ग का तैल से चारो ओर अप्यङ्ग आदि परिचर्या का विधान बतलाया है^१।

After onset of labour pains, the woman should be made to sit on a soft cushion spread over the ground. The women having qualities described earlier and experienced in conducting the labour should encircle and encourage her by consoling and pleasant words.

Suśruta says that the woman for whom auspicious hymns for her welfare and prosperity have already been recited and is ready to deliver, should be encircled by *kumārās* (male children) and hold the fruit bearing masculine name. She should be given massage (with oil), bath with lukewarm water and made to drink good, strength producing rice gruel, filling her stomach to its fullest capacity. Now the woman should sleep in supine position with flexed thighs on a soft bed having pillow and be attended by undaunted, mature and expert four women having their nails trimmed.

Vāgbhata giving the description like Suśruta has not advised presence of *kumārās*. Besides he has specified the hymn as "*kaṭuka-maṅḍala*" and the bed that a soft cushion should be spread over the ground and be covered with skin of red bull. The women attending her should wear intact clothes. The delivering woman should be given repeatedly inhalation of powdered *kuṣṭha*, *ela*, *lāṅgālī*, *vaca*, *cayā*, *citraka* and *citrabīṭva* (any one or all together) or intermittent inhalation of smoke of *bhūjīrapāra*, leaves of *śimśipā* and *sarjārava*. Indu opines that inhalation should be given during inter-contraction period. Gentle massage with lukewarm oil over flanks, back, sacrum and thighs should be done. This procedure brings the fetus down.

Vāgbhata II has advised the massage over infraumbilical region of the delivering woman and repeated yawning and slow walking by her. Arunadatta has explained that oil is massaged to avoid aggravaion of *vāta* and has advised its continuation till expulsion of fetus.

Kāśyapa has written that after observing the clinical features of onset of labour, senior experienced women after taking bath, and having recitation of words for welfare by *bṛāhmanas* should enter the labour ward. These sweet speaking women, urging *prajāpāti* for economic and religious achievements, should console, encourage and delight the pregnant woman, narrate to her the pleasures of children and sorrows of childless couple. They should pray *aditi*, *kaśyapa*, *deva*, *indrān*, *indrā*, *aśvinikūmaras* and auspicious gods who have number of children and long life. The woman anxious to deliver should remain happy, free from shyness and sitting encircled with old women and money should attempt for delivery. He has also advised use of meat soup during this period.

^१. तैलेनाभ्यक्तगान्तां संस्ततामुष्णवारिणा । यवानां पायवेकोष्ठां मात्रया धृतसंयुताम् ।

कृतेनोषाने पृथुनि विस्तीर्णे शयने शनैः । आभुग्नसन्निधौ चोत्तानां नारी तिष्ठेद्व्याघातञ्चला ॥

चतस्रोऽशकनीयाश्च सत्वयो कुशला हिलाः । वृद्धाः परिचरेयुस्ताः सप्यक्लिन्नतलाः स्त्रियाः ॥

अपत्यमार्गे तैलेन समभ्यज्य समन्ततः ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/३४४ से ३४५)

Bhela has advised association of four women friends. Bhāvaṁśīra has added that oil should be massaged all around the vaginal canal.

अ) अनागतप्रसव या गर्भ के अवाक् न होने पर कर्तव्य (Management in case of failure in descent of fetus)

सा चेदावीभिः संकिलश्यमाना न प्रजयेतशैनां ब्रूयन्-जीतिष्ठ, मुसलमन्तरं गृहीष्व, अनेनैतदुलूखत् धान्यपूर्णं महुर्मुर्धभिर्जहि महुर्मुर्ध्वज्जम्भस्व चङ्क्रमस्व चान्ताऽन्तेति, एवमुपदिशन्त्येके । तत्रेत्याह भगवाननेयः । दारुणव्याधामवर्जनं हि गर्भिण्याः सततमुपदिश्यते, विशेषतश्च प्रजननकाले प्रचलितसर्वधातुदोषायाः सुकुमार्या नार्या मुसलव्याधामसमीरितो वायुरन्तरं लब्ध्वा प्राणान् हिंस्यात्, दुष्प्रतीकतमा हि तस्मिन् काले विशेषण भवति गर्भिणी; तस्मान्मुसलग्रहणं परिहायमुषयो मन्यन्ते । नृभ्यो च चङ्क्रमणं च पुनरुद्यमिति । अथास्य दद्यात् कुष्ठैलालाङ्गुलिकोच्चाचित्रकचिराविल्वचव्यचूर्णमुपघ्रात, सा तन्महुर्मुर्धपर्यजयेत्, तथा भूर्जवृक्ष्युं शिंशिपासायुसं वा । तस्याश्चान्ता कटीपार्षदपुष्टसंविश्वदेशानीषदुष्णेन तैलेनाभ्यन्यानुसुखमवधुगीयात् । अनेन कर्मणा गर्भोऽवाक् प्रतिपद्यते ॥ (च० सं० शा० ८/३८)

तत्र प्रतिलोममनुलोमयेत्, प्राञ्जलमार्कषेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/१०)

न चेदेवं परिचरते ततो महुर्मुर्ध्वर्धणं चक्रमणं च कारयितव्याऽन्तरोक्तं विधिम् ॥ २२ ॥

अन्ये तु मुशलेनोल्खत् धान्यपूर्णमाहनीयमित्याहुः । तत्तु न सप्यक् । दारुणव्याधामवर्जनं हि गर्भिण्याः सततमुपदिश्यते । विशेषतश्च प्रसवकाले प्रचलितसर्वधातुदोषायाः सौकुमार्यान्तार्या मुशलव्याधामनेरितो वायुरन्तरं लब्ध्वा प्राणान् हिंस्यादिति ॥ २३ ॥ (अ० सं० शा० ३/२२ व २३)

केचिदस्यामवस्थायां व्याधाम मुसलादिकम् । नृभ्याचङ्क्रमणाद्यं च भिषको ब्रूवते हितम् ॥ वर्जनीयं तु तत्सर्वं भगवानाह कश्यपः । नार्याः प्रसवकाले हि शरीरमुपगृह्यते ॥ त्रयो दोषाः प्रकृयन्ति त्रिचाल्यन्ते च धातवः । गर्भिणी तदवस्था हि यन्तार्या विशेषतः ॥ अधिकं सौकुमार्यं हि गर्भिण्याः क्लेशमेव च । सावकाले विशेषण विषादभयसंश्रयः ॥ एकपादो यमकुले पाद एक इह स्थितः । दुष्ट्वा दुःखं स्त्रियास्तस्या इत्येवं ब्रूवते मिथः ॥ तस्यास्त्वस्यामवस्थायां व्याधायो न प्रशस्यते । व्याधायः सेव्यमानो हि गर्भिणीमारु नाशयेत् ॥ अतिचङ्क्रमणेनानपि इत्यादयर्मपुस्थितम् । अत्यं प्रागुयाद्धोरं देहान्तकरणं महत् ॥ वचा लाङ्गुलिकी कुष्ठं चिरबिल्वचैल्विचक्रकाः । चूर्णितं मुखं (हृ) प्रजिघ्रेतश्चा शीघ्रं प्रजायते ॥ आजिघ्रेद्भूर्जवृक्षं वा नमेरोर्गुणुलोस्तथा । अथ घः प्रपद्यते गर्भस्तथा क्षिप्रं विमुच्यते ॥ पार्षदसंविश्वकटीपुष्टं तैलेनोष्णेन प्रक्षितम् । पृदगीयुरवकषेयुः शनैः प्राज्यः स्त्रियः सुखाः (खम्) ॥ दुर्बलां पायवेनमहामित्येके, नेति कश्यपः । पूर्वोक्तिश्चा तथैवास्या (उसी) यवानां तुषिता भिबेत् ॥

(का० सं० शा० ५/३२ से ३८, ४० से ४३)

यदि आनी से क्लेश पाती हुई स्त्री को प्रसव न हो तो उससे कहे कि उठो, मुसल या अन्य कोई चीज लो, धान्य से भरे हुए ऊखल में बार बार चोट मारो (कुटो), बार बार जमहाई लो, बीच-बीच में घूमो इस प्रकार का उपदेश कुछ आचार्य देते हैं । भगवान् आश्रय कहते हैं कि ऐसा नहीं है, गर्भिणी स्त्री को कठिन व्यायाम हर समय वर्ज्य करने का उपदेश दिया गया है, विशेषकर प्रजननकाल में संभौ दोष एवं धातुओं के प्रचलित होने के कारण सुकुमारि नारी में मुसल के व्यायाम से प्रकृति वायु अवकाशों में जाकर प्राणों की हिंसा कर देती है । गर्भिणी विशेषकर इस काल में दुष्प्रतीकतम होती है इसलिए मुसल-ग्रहण आदि व्यायाम वर्ज्य हैं ऐसा श्लेषियों का मत है । जम्माई लेना तथा घूमना श्रेयस्कर है तथा इसे कुष्ठ, एला, लाङ्गुली, वचा, चित्रक, चिरबिल्व एवं चव्य का चूर्ण सूंघने को दे, वह स्त्री इन्हें बार-बार सूँघे, इसी प्रकार

भूजपत्र अथवा शिशिया-सार (शीसम के सत्व या नियर्स) का घूम सूँघ इसके अन्तर (धूम आदि सूँघने के बीच में) कटि, पार्श्व, पृष्ठ एवं सक्थिप्रदेश में ईन्द्रियुष्ण तैल से अभ्यङ्ग करके धीरे-धीरे दबावे। इस काम से गर्भ अवाक् (नीचे की ओर) हो जाता है।

महर्षि सुश्रुत ने संक्षेप में लिखा है कि प्रतिलोम को अनुलोम करना चाहिए एवं प्राञ्जल या सीधे को (नीचे की ओर) आकृष्ट करना चाहिए। टीकाकार डल्हण ने इसे अनेक प्रकार की मृदुःगर्भ की गतिओं एवं उनकी चिकित्सा का निर्देश-मार्ग माना है एवं लिखा है कि अप्रतिलोम या अनुलोम को प्राञ्जल (सीधा) ही खींचना चाहिए।

अष्टांगसंग्रहकार ने लिखा है कि यदि गर्भ परिवर्तित नहीं होता (नीचे की ओर नहीं आता) तब (गर्भिणी को) बार-बार जम्हाई लेना एवं घूमना चाहिए तथा अन्यत्र वर्णित (कुष्ठैलादि उपप्राण तथा ईन्द्रियुष्ण तैल से कटि आदि का मर्दन) उपाय करना चाहिए। अन्य आचार्य धान्य-पूर्ण ऊखल को मूसल से चोट करने को कहते हैं, यह उचित नहीं है, गर्भिणी को हमेशा कठिन व्यायाम वर्जित बताया गया है, विशेषकर प्रसव-काल में सभी धातु एवं दोषों के प्रचलित होने एवं स्त्री के सुकुमार होने के कारण मूसल आदि के व्यायाम से प्रकुपित वायु अवकाशों में जाकर प्राणों का नाश कर देती है।

काश्यप संहिता में लिखा है कि कुछ चिकित्सक इस अवस्था में मुसलादि का व्यायाम, जम्हाई तथा चक्रमण आदि को हितकारी कहते हैं परन्तु भगवान् काश्यप का कहना है कि ये सब चूर्वनीय हैं क्योंकि प्रसवकाल में स्त्री का शरीर मृदु होता है, तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं तथा सभी धातुयें विचलित हो जाती हैं अतः इस अवस्था में गर्भिणी बहुत ही यत्नपूर्वक धारण करने योग्य होता है। गर्भिणी अति सुकुमार होती है, उसमें क्लोद की अधिकता होती है विशेष कर साव-काल में (प्रसव-काल में) विषाद तथा भय होता है (स्त्री को दुःख तथा उपद्रवों का पय होता है)। अन्य सिद्धियाँ उसके काष्ठ को देखकर कहती हैं कि इसका एक पैर यम के घर में या यमलोक में तथा एक पैर इषर अर्थात् इस लोक में है; अतः इस अवस्था में उसे व्यायाम हितकारी नहीं है। सेवन किया गया व्यायाम गर्भिणी का शीघ्र ही विनाश कर देता है। अन्वयिक घूमना भी उपस्थित गर्भ (प्रसव के लिए उद्यत गर्भ) का हनन तथा अन्य थोर देहात्मिकारी रोग उत्पन्न करता है (अतः अति चक्रमण नहीं करना चाहिए परन्तु सुख चक्रमण किया जा सकता है)। जवा, लाङ्गली, कुष्ठ, चिरवित्त, एला एवं विचक्र के चूर्ण को बार-बार सूँघने से शीघ्र ही प्रसव हो जाता है तथा भूर्जपत्र, नमेरु (सुरपुञ्जा) एवं गुग्गुलु के चूर्ण को सूँघने से गर्भ नीचे आ जाता है तथा शीघ्र ही अपने स्थान से छूट जाता है (अर्थात् स्वस्थान या गर्भाशय से निकल कर बाहर आ जाता है)। कुशल सिद्धियाँ उष्ण तैल से पार्श्व, सन्धि, पृष्ठ एवं कटि का सुखपूर्वक अभ्यङ्ग करती हुई गर्भ को धीरे-धीरे नीचे की ओर खींचे या लाने का प्रयत्न करें। कुछ आचार्यों का कहना है कि दुर्बल सिद्धियों को मद्यपान कराये पर महर्षि काश्यप कहते हैं कि यह नहीं करना चाहिए। पहिले से ही काष्ठ से पीड़ित इस स्त्री को प्यास लगने पर यवागू का पान करावे। अन्यत्र भी महर्षि काश्यप ने गर्भधारण से लेकर प्रसव के सम्पूर्ण हो जाने तक की चिकित्सक की आगुता का वर्णन किया है कि कब पत्नी भौति प्रसव पूर्ण हो जाए, क्योंकि इस प्रसव-काल में स्त्री का एक पैर इस ओर (संसार की ओर) तथा दूसरा यमलोक में रहता है अर्थात् तनिक भी देरी या तापवाही से स्त्री की मृत्यु तक हो सकती है।

महर्षि भेल ने लिखा है कि इस स्त्री को एक अक्षर रक्त-शाली को अस्त (काँजी) एवं मूत्र के साथ पिलावे। इसी कल्प के साथ दन्ती, द्रवन्ती, वृद्धिकाली, पुनर्नवा तथा बनशीर्षक (बनघटेल) को पिलाये। इस काल में पुराना शाली या

१. प्रतिलोमला चानेकप्रकारा मूढगर्भान्तिनोक्त्या दिशा ज्ञातव्या। अनुलोमयेदिति मूढगर्भचिकित्सोक्तप्रकारोपेक्ष्यः॥
अप्रतिलोमनु प्राञ्जलमाकर्षेत्॥ (सुं सं० शां० १०/१० की डल्हण टीका)

२. गर्भात् प्रपुति सूतायां पिपपभवति कार्यवान्। कथं नु काले सम्पूर्णं सूयेदित्यपपपप॥४॥

प्राप्ते प्रसवकाले च भयमुत्पद्यते यतः। अस्मिन्नेकः स्थितः पादो भवेदत्यो यमक्षेत्रे॥५॥ (का० सं० छि० ११/४५)

अन्य वस्तुयें पीने को दें। यदि इस विधि से प्रवर्तन न हो तो तीक्ष्ण तैल से अनुवासन दें।

If the woman, inspite of having labour pains does not deliver, then she should be asked to get up and holding a pestle or any other heavy thing should strike the paddy filled in mortar, should yawn repeatedly and walk inbetween, is the opinion of few. Atreya contradicting this says that heavy exercise is always contraindicated to a pregnant woman; specially during delivery, because at this time all the *doshas* and *dhatuas* of body are moving or are excited, thus the *vāyū* of delicate woman getting excited due to exercise with pestle etc. enters the hollow spaces of the body and kills her. The treatment of woman at this stage is very difficult, considering this the use of pestle etc. is contraindicated, however, yawning and walking is beneficial. Inhalation of powdered *kushtha*, *elā*, *lingālī*, *vaccā*, *citrakā*, *citrabīva* and *carya* or smoke of *blūrjapāra* or resin of *śinśīpā* should be given; in-between massage with lukewarm oil over waist, flanks, back and thighs, then gentle kneading should be done. By this process the fetus descends downwards.

Suśruta says that fetus having gone to opposite or wrong direction should be brought to right direction and the one which is straight should be pulled or extracted. Dahhana has explained that this is just a hint for the management of obstructed labour.

Vāgbhaṭa I has expressed almost identical opinion as given by Caraka.

Kāśyapa expressing opinion about different exercises just like Caraka explains that besides displaced *doshas* and *dhatuas*, the woman has predominance of *kleda* (humidity) also, thus is more vulnerable for diseases and sorrows. Other women observing her agony remark that her one foot is in the house of *yama* (the god of death) and other on this side (i.e. she can die at any moment). Any exercise can kill the pregnant woman immediately, even excessive walking can kill the delivering fetus and produce several fatal disorders. He has also advised inhalations, (instead of *śinśīpā* he has written *namru* and *guggulū*) and oil massage etc. Few authors advise use of wine for weak women, however, Kāśyapa has contradicted this and advised use of rice gruel to quench the thirst.

Bhela says that one *akṣa* boiled red *śālī* rice mixed with sour drinks and (cow) urine should be given or else this rice should be given with decoction of *damū*, *dravāmī*, *prścikālī*, *punarnava* and *banatikāka*. Gruel made with old *śālī* rice is also prescribed. If fetus does not descend with this, then *anuvasāna basti* with pungent oil should be given.

इ) प्रसव के लिए स्त्री को प्रवाहण करने का निर्देश, प्रवाहण के समय परिचारिका का कर्तव्य एवं अकाल-प्रवाहण का परिणाम (Instructions to make bearing down efforts, duties of accoucheuse and effect of undue bearing down)

ताश्चैनं यथोक्तगुणः स्थियोऽनुशिशुः—अनागतावीर्मा प्रवाहिच्छाः, या ह्यनागतावीः प्रवाहते व्यर्थमेवास्यास्तत्

१. त(अ)थैनां रक्तशालीनामक्षमात्रं कल्पमस्तेन मूत्रेण पाययेत्। एतेनैव कल्पेन दन्ती द्रवन्ती वृद्धिकाली पुनर्नवा बनशीर्षक कारयेत्। तफ(दि)म(मो)काले सर्वगुणमात्रा(शाली)नामन्यत्वेन पाययेत्। सा चेदनेन विधिना न प्रवर्तते, अथैनं तीक्ष्ण-तैवे(ले)नागु(वासयेत्)॥ (बनशीर्षक कारयेत् का शुद्धपाठ-वर्तितिकानि पाययेत्)॥ (भे० सं० शां० ८/८)

कर्म भवति, प्रजा चास्या विकृता विकृतिमापन्ना च, श्वासकासशोषलीहप्रसक्ता वा भवति । यथा हि क्षवधूद्गारवातमृदुपुरीषवेगान् प्रयतमानोऽप्यप्रसक्तालात्र तन्मते कृच्छ्रेण वाऽप्यवाप्नोति, तथाऽज्जातकालं गर्भमपि प्रवाहमाणाः यथा चैषामेव क्षवध्वादीनां सञ्चारणमुपधातायोपपद्यते, तथा प्रसक्तालस्य गर्भस्याप्रवाहणमिति । सा यथानिर्देशं कुरुष्वेति वक्तव्या स्यात् । तथा च कुर्वती शनैः पूर्वं प्रवाहेत ततोऽनन्तरं बलवन्तरम् । तस्यां च प्रवाहमाणायां स्त्रियः शब्दं कुर्युः—'प्रजाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रम्' इति । तथाऽस्या हर्षेणाप्यायन्ते प्राणाः ॥ (च० सं० शा० ८/४०)

.....अनुब्रूयाच्चैतामेका—सुभगे प्रवाहस्वेति नवाप्रासावी प्रवाहस्य, ततो विमुक्ते गर्भनाडीप्रबन्धे सशूलेषु श्रोणिवक्षप्रवर्तितशिरःसु च प्रवाहेशः शनैः शनैः, ततो गर्भनिर्गमे प्रगाढम्, ततो गर्भं योनिमुखं प्रपन्ने गाढतमाविशत्यभवात् । अकालप्रवाहणाद् बधिरं मूकं व्यस्तहनुर्गर्भीभयातिनं कामश्वासशोषोपद्रुतं विकटं वा जनयति ॥ ८॥ (सु० सं० शा० १०/१)

तथा पराऽनुशिष्यात् । अनागातायां वेदनायां मा प्रवाहिष्यः । अकालप्रवाहणं हि विषमूत्रादिवेगानामि-
वोदीरणमनर्थकमहितं च गर्भस्य श्वासकासशोषकुब्जतादिकारित्वात् । तथा तेषामेव विधारणपिव
वेदनायामप्रवाहणमुपधाताय ॥ ३०॥

ततो यथेके कुरुष्व शनैः शनैश्च पूर्वं प्रवाहिष्यः । निर्गमे बाहं गर्भस्य योनिमुखप्रतिपत्तौ बाढनमाप्रस-
वादिति ॥ ३१॥

तस्यास्तु प्रवाहमाणायाः स्त्रियाः शब्दं कुर्युः प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रमिति । तथाऽस्या हर्षेण प्राणा
आप्यायन्ते ॥ ३२ ॥ (अ० सं० शा० ३/३० से ३२)

मृदुपूर्वं प्रवाहेत बाढमाप्रसवाच्च सा ॥ ८१॥

हर्षयेत्तं मधुः पुत्रजन्मशब्दजलानिर्लेः । प्रत्यायाति तथा प्राणाः सूक्तिलेशोपवसदिति ॥ ८२॥
(अ० ह० शा० १/८१, ८२)

उस स्त्री (प्रसविनी स्त्री) को यथेक गुण (पूर्ववर्णित प्रजनन कुशल, परिणत वयस्क आदि) वाली स्त्रियाँ शिक्षा दें:-

अनागत आवाी (प्रसव वेदना को अनुपस्थिति) में प्रवाहण मत करो । जो अनागत आवाी में प्रवाहण करती हैं उनका वह कर्म (प्रवाहण कर्म) व्यर्थ जाता है (गर्भ को प्रसव-मार्ग में गति नहीं बढ़ती) तथा उसकी सन्तान विकृत अथवा विकृतियों से आक्रांत होती है, वह खांस, कास, शोष या प्लीहा रोग से पीड़ित होती है । जिस प्रकार क्षवधू, उद्गार, वात, मूत्र एवं पुरीष के वेग प्रयतमान होते हुए भी (निकलने के लिए प्रयत्न किये जाते हुए भी) उचित काल (वेग की परिपूर्णता का काल) न होने पर बाहर नहीं निकलते अथवा बहुत कष्ट से निकलते हैं उसी प्रकार अनागत काल (आवाी की अनुपस्थिति) में प्रवाहण करने से गर्भ भी बाहर नहीं निकलता, एवं जिस प्रकार क्षवधू इत्यादि वेगों के आने पर उनका सम्भ्राण उपधातकारक होता है उसी प्रकार प्रसक्ताल (आवाी के आने पर) होने पर गर्भ का प्रवाहण न करना भी हािनकारक होता है । अतः वह (पारिचारिका) स्त्री (प्रसविनी स्त्री) को कहे कि निदेशानुसार प्रवाहण करो । प्रवाहण प्रारम्भ में (द्वितीयावस्था के प्रारम्भ में) धीरे-धीरे तत्पश्चात् बलपूर्वक करना चाहिए । उसके प्रवाहण करते समय स्त्रियाँ ये शब्द कहे कि "उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, धन्य हो, धन्य हो, पुत्र उत्पन्न हुआ । इससे हर्ष के कारण प्राणों को बल मिलता है ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि उनमें से एक (पारिव्यां करती हुई चार स्त्रियों में से केवल एक अथवा चारों में एक

उंठी आवाज में एवं अन्य धीरे धीरे^१ कहे कि है सुभगे । प्रवाहण करो, आवाी (प्रसव-वेदना) न होने पर प्रवाहण मत करो, तत्पश्चात् गर्भनाडी के प्रवध (गर्भ को नाडी के कठिन वन्धन) खुल जाने पर एवं श्रोणि, वक्षप्र तथा यस्तिशिर में शूल होने पर पहिले धीरे धीरे प्रवाहण करो, गर्भ के निर्गम के समय (स्वस्थान से गर्भ के निकलने के लिए नीचे आने के समय) जोर से प्रवहण करो, गर्भ के योनिमुख में आ जाने पर विश्रालीभाव होने तक (गर्भ रूपी शल्य के पूर्ण रूप से बाहर निकल जाने तक) अतितीव्र प्रवाहण करो । टीकाकार उल्लहण ने गर्भ के साथ ही अपात निकलने तक तीव्र प्रवाहण का निर्देश दिया है^२ । अकाल में प्रवाहण करने से (स्त्री) बधिर, मूक, व्यस्तहनु (हनुसंधि का टूट जाना), ऊर्ध्वाभिघाती (ऊर्ध्व जंघु-गल रोगों से पीड़ित), कास, श्वास एवं शोष आदि से उपद्रुत या पीड़ित तथा विकट (अयथास्थान अङ्गों वाली) सन्तान का जन्म देती है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि अन्य स्त्री (वहाँ उपस्थित पारिचारिकाओं में से एक) शिक्षा दे कि वेदना न होने पर प्रवाहण मत करो, क्योंकि असमय में प्रवाहण अनुपस्थित मल-मूत्रादि के वेगों के प्रवृत्त करने के प्रयत्न के सदृश ही अनर्थकारी एवं अहितकारक है, तथा गर्भ को श्वास, कास, शोष तथा कुब्जता आदि उत्पन्न करने वाला होता है, एवं इनके (मल-मूत्रादि के वेगों के) धारण सदृश ही वेदना की उपस्थिति में प्रवाहण न करना हािनकारक होता है । तत्पश्चात् यथेक विधि से पहिले धीरे-धीरे प्रवाहण करना चाहिए, गर्भ के बाहर निकलने पर (श्रोणिगुहा में नीचे आने पर) कुछ तीव्र प्रवाहण करना चाहिए एवं (गर्भ के) योनिमुख को प्राप्त हो जाने पर प्रसव पूर्ण होने तक अति-तीव्र प्रवाहण करना चाहिए । उस प्रवाहण करती हुई स्त्री के पास अन्य स्त्रियाँ ये शब्द कहे कि "प्रसव हो गया, प्रसव हो गया, धन्य हो, धन्य हो, पुत्र उत्पन्न हुआ" । इससे हर्ष के कारण प्राणों को बल पहुँचाता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने संक्षेप में लिखा है कि प्रारम्भ में धीरे धीरे तत्पश्चात् प्रसव पूर्ण होने तक जोर से प्रवाहण करो । उसको पुत्र-जन्म के शब्द तथा जल एवं वायु से (जल के छीटे देकर तथा हवा करके) बार बार प्रसव करो इससे प्रसव के क्लेश से धके हुए प्राण लौट आते हैं । टीकाकार अरुणदत्त ने स्मष्टीकरण में अष्टाङ्गसंग्रहांक वर्णन को ही 'शनैः शनैः से' प्रसवादि^३ तक तथा अकाल प्रवाहण से होने वाले गर्भोद्भ्रव एवं अप्रिम पृष्ठों में वर्णित 'क्षितिर्बलं' आदि मंत्र उद्धृत कर दिया है ।

महर्षि भेल ने भी लिखा है कि पहिले धीरे-धीरे बाद में जोर से प्रवाहण करो, वेदना न होने पर प्रवाहण न करो, बिना वेदना के प्रवाहण करने से स्वयं एवं पुत्र दोनों को विकार हो जाते हैं ।

आचार्य भावमिश्र ने भी महर्षि सुश्रुत सदृश ही प्रवाहण-निर्देश दिया है कि पहिले धीरे-धीरे बाद में जोर से एवं गर्भ के योनिद्वार में आ जाने पर अत्यधिक जोर से अपरा के निकलने तक प्रवाहण करो । अकाल में स्त्री प्रवाहण न करे क्योंकि अकाल में प्रवाहण से मूक, बधिर, कुब्ज, श्वास-कास से पीड़ित एवं सस्त-हनु वालक का जन्म होता है ।

१. एका उक्तुष्य, अन्ये त्वेका चतसृणां स्त्रीणां मध्ये^४ इति व्याख्यानयति । आवाी प्रसववेदना..... । ततो विमुक्ते गर्भनाडीप्रबन्ध इति गर्भनाडीनां प्रकृष्टे बन्धस्तस्मिन् । स्वस्थानाद् गर्भस्य निःसराण्य गगनं गर्भनिर्गमस्तस्मिन् गर्भनिर्गमे । आविशत्यभवादिनि शल्यग्रहणमपराधितगर्भात्पत्यं । । व्यस्तहनु विधाटोमुखसन्निभ । उर्ध्वाभिघातिनम् ऊर्ध्वजंघुगतोयोगिणम् । विकटम् अयथास्थाननिवेशितवयस्यं ॥ (सु० सं० शा० १०/१ को डहरे० टीका)
२. अ० ह० शा० १/८१, ८२ की अरुण० टीका
३. शनैः पूर्वं प्रवाहा(हेतु)पश्चाद्वलवर्तमिति, न चाप्यनगमवेगा बाहिराह(विश)तया, ह्यनागतवेदुःख वा आत्मानं प्रपच्छति सा(ह)नुप(दुःप्रयसे), तस्याश्चैत्यजालात्(तोऽपि) अप(विका)रात् प्रपद्यते । (शे० सं० शा० ८/८)

४. एका तु तासु सुभगे प्रवाहस्वेति तां वेदत् ॥ ३४०॥

अथवा मा प्रवाहिष्यः प्रवाहेष्व व्यथा यदि । प्रवाहेषः शनैः पूर्वं प्रगाढं च ततः परम् ॥ ३४८॥

ततो गाढनमं गर्भं योनिद्वारमुपागते । अपरासहितो गर्भो यावत्सतति भूतले ॥ ३४९॥

मूकं वा बधिरं कुब्जं श्वासकासक्षयाविवर्तितम् ।

सूते सस्तहनु(हनु-शु० पा०) बालमकले तु प्रवाहणात् ॥ ३५०॥ (शा० प्र० पूर्व ३/३४९ से ३५०)

The accoucheuse or female attendants should educate the woman "do not bear down in the absence of labour pains, because it would be useless (in terms of progress of labour). One who does it, her child becomes abnormal, deformed or afflicted with dyspnoea, cough, emaciation and diseases of spleen. In the absence of natural urge inspite of best efforts as one either does not get or gets with difficulty sneezing, eructation, flatulency, urine and feces, similarly bearing down efforts made in the absence of labour pains do not bring the fetus down. As suppression of sneezing etc. natural urges is harmful, similarly absence of efforts to bear down during labour pains is also harmful". Considering this the woman should bear down as instructed by accoucheuse. Initially (early second stage) the bearing down efforts should be mild, but should be forceful at the end. At the moment of this bearing down the attendants should pronounce "delivered, delivered, you are fortunate, fortunate, you have delivered a male child." Hearing these words the woman gets strength due to happiness.

Suśruta also has advised not to bear down in the absence of labour pains. When the fetus (presenting part) has slightly descended and the pain is felt in the region of pelvis, groin and neck of urinary bladder, the bearing down efforts should be gentle, when the fetus descends further then stronger and when the fetus (vertex) has appeared at the vaginal orifice, then bearing down efforts should be strongest till the fetus has delivered. Dahhaṇa opines that the efforts should be continued upto the expulsion of placenta. Deafness, dumbness, dislocation of mandible, diseases of head and neck, cough, dyspnoea and emaciation etc. diseases and abnormal location of body-parts of the child are likely to occur due to bearing down efforts made in the absence of labour pains.

Vāgbhaṭa I has followed Caraka, but has added humpback in the disorders of fetus occurring due to improper bearing down efforts. Method of bearing down is described just like Suśruta. Vāgbhaṭa II, Bhela and Bhāvanāśīra have also expressed almost similar views.

ई) गर्भ के अवाक हो जाने पर कर्तव्य (Management after descend of fetus)

अस्यामवस्थायां पयङ्कुमेनामारोप्य प्रवाहयितुमुपक्रमेत । कर्णे चास्या मन्त्रिममनुकृता स्त्री जघेत्-
'क्षितिर्वर्तते विद्यतेजो वायुर्विष्णुः प्रजापतिः । सार्धं त्वां सदा पानु वैशत्यं च दिशन्तु ते ॥
प्रसूष त्वमविक्षिप्तमविक्षिप्ता शुभानने ॥ कार्तिकेयवृत्तिं पुनं कार्तिकेयाभिरक्षितां ॥' इति ।
(च० सं० शा० ८/३९)

अथास्या विशिखान्तरमनुलोममनुसुखमप्यच्य॥ (सु० सं० शा० १०/९)

अथ परिवृत्तगर्भा पयङ्कुमेनामारोप्य कुशला स्त्री पादतोऽस्या निषण्णया योनिमनुलोममनुसुखमप्यच्य स्मिकर्णो
पादाभ्यां योजयेत् । योनिं च पुनः पुनः प्रसारयेत् । दूयाच्च सुभगे शनैः शनैः प्रवाहयच्च सुप्रसन्नस्ते मुखवर्णः पुनं
जनीयष्यतीति ॥ २४॥

अस्या तु वामकर्णोऽस्या मन्त्रमिमं जघेत् ॥ २५॥
क्षितिर्वर्तते पातु वैशत्यं वा दयात्वयि ॥ २६॥
प्रसूष अभिरक्षिताम् ॥ २७॥ इति । (चक्र सं० सदृश है)

तथा-

इहापुनं च सेमश्च चित्रमानुश्च भूमिनि । उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ २८॥

इदमनुमममां समुद्धृतं वै, तत्र लघु गर्भमिमं प्रमुञ्चतु स्त्रि ।
तदनलपवनार्कवासवासे, सह लवणाधुष्यैरिदं शान्तिम् ॥ २९॥ इति । (अ० सं० शा० ३/२४ से २९)
.....खट्वामारोपयेततः ।

अथ समीडिते गर्भे योनिमस्याः प्रसारयेत् । (अ० ह० शा० १/८०, ८१)

अथास्याः प्रसवयेति ततः पयङ्कुमारहेत् । प्रवारमुपधानं वा॥ (का० सं० शा० ५/४६, ४७)

इस अवस्था में (गर्भ के अवाक हो जाने पर) (उस स्त्री को) पलङ्ग पर लिटाकर प्रवाहण करने के लिए कहे तथा उसके कान में अनुकूल स्त्री इस मंत्र को जपे "पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, विष्णु एवं प्रजापति तुम्हें गर्भ-युक्त की रक्षा करें तथा तुम्हें शल्य से विरहित कर दें । हे शुभानने ! तू क्लेश से विरहित होते हुए (बिना किसी कष्ट के), अविक्षिप्त (क्लेश या धक्कादि से रहित), कार्तिकेय से अभिरक्षित कार्तिकेय के सदृश ही पुत्र को उत्पन्न करे" ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि (यद्यपि सुश्रुत में निम्नांकित क्रिया करने के लिए विशिष्ट समय निर्दिष्ट नहीं है परन्तु यह गर्भ अवाक हो जाने पर ही करने योग्य होने से यहाँ वर्णित है) अब इस स्त्री के अपत्यमार्ग में लोभों के अनुकूल (रोमों के प्रतिकूल अप्यङ्ग करने से उनके टूटने या वेदना का भय रहता है) सुखपूर्वक अप्यङ्ग करे ।

अष्टाङ्गसंहकार ने लिखा है कि परिवृत्त-गर्भा स्त्री को पलङ्ग पर लिटाकर कुशला (प्रजनन कर्म कुशल) स्त्री पैरों की ओर बैठकर योनि का अनुलोम एवं सुख-पूर्वक अप्यङ्ग करके स्मिकों को पैरों से दबावे । बार-बार योनि का प्रसारण करे एवं कहे 'हे सुभगे ! धीरे-धीरे प्रवाहण करो । तुम्हारे मुख का वर्ण सुप्रसन्न है (सुन्दर है), पुत्र का जन्म करोगी' । अन्य स्त्री वामकर्ण में इस मंत्र को जपे 'पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, विष्णु और प्रजापति गर्भ-युक्त तेरी रक्षा करें तुम्हें शल्य से रहित करें । हे शुभानने ! तू बिना क्लेश के, कष्ट से रहित, कार्तिकेय से अभिरक्षित, कार्तिकेय के ही सदृश पुत्र उत्पन्न करे' तथा- 'इसी प्रकार अमृत, सोम, चित्रमानु, भूमिनी तथा उच्चैःश्रवा नामक अष्ट तेरे मन्दिरे में निवास करें (या तेरे घर में रहकर तेरी रक्षा करें) । हे स्त्री ! जल से उद्धृत (समुद्र-मन्थन से) यह अमृत तेरे लघु गर्भ को मुञ्चित करा दे एवं अग्नि, वायु, सूर्य, इन्द्र तथा समुद्र तुम्हें शान्ति दें ।'

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि (गर्भ अवाक हो जाने पर) इसे पलङ्ग में लिटाकर गर्भ के समीप होने पर (गर्भ का वायु के द्वारा चारों ओर से सम्पीडन हो नीचे आ जाने के कारण योनि-मार्ग में दबाव पड़ने पर) इसकी योनि का प्रसारण करे (अप्यङ्गादि के द्वारा विकास करे) ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि अब इसे प्रसव होगा ऐसा जानकर प्रवार (चदर) तथा उपधान (तिकाया) युक्त पलङ्ग पर लिटा दे,॥

When the fetus has descended down-wards, the woman should be made to lie down on the bed and be advised to bear down. Another agreeable woman should recite repeatedly in low voice the *mantra* "pṛthivī, jala, dāśā, teja, vāyu, viṣṇu and prajāpati should protect you the woman ! carrying fetus and make you free from this śalya (fetus acting as foreign body). O beautiful woman ! you deliver without any difficulty the child free from troubles and tiredness and who is protected by Kārikēya and resembles him."

Suśruta has advised pleasing massage of genitalias in the direction of hair (in opposite direction the hair may get uprooted causing pain).

Vāgbhaṭa I following Caraka adds that the accoucheuse should sit towards the foot end

१. विशिखान्तरम अपत्यमार्गम् । अनुलोमं लोमानुकूलं॥ (सु० सं० शा० १०/९ का इच्छण टीका)

२. गर्भे समीडिते-समन्तात्सीडिते, वायुना योनिमुखात्तन्तरया, अस्या गर्भिण्या योनिं प्रसारयेत्-अप्यङ्गादिदिनेन विकासयेत् ॥

(अ० ह० शा० १/८१ की अलण टीका)

of delivering woman and gently massage the genitalias in the down-ward direction, should compress the hips with her foot, repeatedly dilate the vaginal canal and say 'O beautiful lady ! bear down slowly, your facial expression is charming, you will deliver a male child'. Besides recitation of *mantras* advised by Caraka, he has added two more i. e. "Similarly *amritam, soma, citrabhānu, bhāmini* (a beautiful young woman) and horse named *uccaiṣṭhravā* should live in your house (and protect you). O Woman ! this nectar obtained by churning the sea should expell your small fetus; *agni, vāyu, sūrya, indra* and *samudra* should give you solace".

Vāgbhata II and Kāśyapa have expressed similar views but in summarized way.

(उ) गर्भसङ्ग-विकृतिस्तथा प्रसव में विलम्ब होने पर प्रयुक्त औषधियाँ (Treatment of *garbhasaṅga* or *delayed labour*)

महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट ने गर्भसङ्ग को विकृतिस्तथा का तो वर्णन किया है परन्तु गर्भसङ्ग के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन नहीं किया। गर्भसङ्ग का अर्थ है गर्भ का चिपक जाना अर्थात् उसकी प्रसव के लिए होनेवाली गति में रुकावट हो एक ही स्थान में स्थित हो जाना। योगरत्नाकरकार तथा आचार्य भावमिश्र ने गर्भसङ्ग शब्द ने देकर 'प्रसव में विलम्ब होने पर' की विशिष्ट विकृतिस्तथा का निर्देश दिया है, जिस विकृतिस्तथा का उद्देश्य भी प्रसव को शीघ्रता से पूर्ण कराना ही है, चूँकि दोनों ही स्थितियों में कोई विशिष्ट भेद नहीं है अतः एक साथ ही वर्णन दिया जा रहा है। अन्यत्र शुक्रस्य वायु के कारण भी गर्भ के सङ्ग होने का उल्लेख है।^१

Suśruta and Vāgbhata have prescribed certain drugs for the treatment of *garbhasaṅga* without elaborating its clinical features. The word *garbhasaṅga* denotes attachment of fetus or cessation in the progress of labour. Books Yogaratnakāra and Bhāvaprakāśa have not used the term *garbhasaṅga*, but have prescribed certain drugs for the treatment of "delay in labour". Since both the conditions are actually the same, hence all the prescriptions are recapitulated at one place.

Vitiated vāyu located in *śukra* is also said to cause *saṅga* or delay in labour.

(१) बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ (Drugs to be used externally)

अ) योनि में धूपन अथवा लेपन (Fumigation or anointment of vaginal canal)

- (१) गर्भसङ्ग में योनि का कृष्ण रस के चुल अथवा पिण्डीतक से धूपन करना चाहिए^{१,३,३४,५५}।
- (२) पोतकीमूल कल्क को तिल के साथ मिलाकर योनि के अन्दर लेप करने से स्त्री सखपूर्वक प्रसव करती है^{५५}।
- i) Fumigation with slough of black snake or *pīṇḍīṭaka* should be done.
- ii) Anointment of pestled root of *potaki* with oil of *tīla* inside the vaginal canal brings easy delivery.

आ) औषधि धाराण अथवा अन्य अङ्गों में लेप (Amulet of drugs or anointment over other parts of body)

- १) हिरण्यपुष्पी (स्वर्णक्षीरी-हिरणी*) के मूल को हाथ पैर में बाँधे या सुवर्चला अथवा त्रिशला का धारण^{१,३,३४,५५}

१. अ० सं० नि० १५/१५, १६; अ० नि० १५/१३ (पृष्ठ १७९)

* Euphorbia thomsoniana.

नोट- औषधियों के सन्दर्भ पृष्ठ ४५४-४५५ में देखें।

करे। इससे शीघ्र ही प्रसव होता है^{५५}।

२) इक्षु या ताल वृक्ष की उत्तर की दिशा की ओर के मूल को स्वशरीर प्रमाण के सूत्र में बाँधकर कमर में बाँधने से शीघ्र ही सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है^{५५}।

३) प्रत्यक्षपुष्पा, पारिभद्र अथवा काकजम्बा के मूल को कटि में बाँधने से स्त्री को शीघ्र ही सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है^{५५}।

४) कृष्ण तथा चचा को जल से पीस एण्ड-तैल के साथ मिला नाभि में लेप करने से अनेकों कष्टों से पीड़ित स्त्री भी सुखपूर्वक प्रसव करती है^{५५}।

Following methods bring easy delivery—

- i) Root of *hiranyapuspi* should be tied over arms or legs or else *suvarcalā* or *viśalyā* should be used.
- ii) Roots of *ikṣu* or *tāla* grown on northern side knotted in a thread measuring to the length of the woman should be tied in waist.
- iii) Root of *pariyakuspā, pāribhadrā* or *kākañgaṅghā* should be tied in waist.
- vi) Anointment of *kṛṣṇā* and *vacā* pestled with water and mixed with castor oil over umbilicus.

इ) सूतिकागृह में स्थापन (Placement over labour ward)

१) कलङ्कीभूत (अस्थि-भण शेष) गोमूर्द्धा (गाय के सिस्) को सूतिकागृह के ऊपर स्थापित करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है^{५५}।

Skeleton of cow's head should be placed over labour ward.

२) मन्त्र-विकृतिस्तथा (Treatment with mantras)

- १) गर्भ के अवाक् हो जाने के पश्चात् कर्तव्यान्तर्गत अष्टाङ्गसंग्रह वर्णित अमृत, सोम एवं जल से उद्धृत अमृत आदि दो मन्त्र (पृष्ठ ४५०, ४५१)।
- २) सभी प्रकार के पाश (बंधन) विपाश (विशिष्ट बंधन) छूट गए हैं सूर्य के द्वारा रश्मियाँ छोड़ दी गई हैं, गर्भ सभी भयों से मुक्त हो गया है अब (गर्भ तु) देर न कर, देर न कर, स्वाहा^{५५}।
- ३) जल को सात बार च्यवन-मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके उसे स्त्री को पिलाकर उभयपार्श्विक यंत्र (अर्थात् जिस यंत्र में दोनों ओर या ऊपर नीचे या सामने जोड़ने से तीस की संख्या आए), दिखाने से शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। कला (१६), रस (६) एवं आठ; पक्ष (२), दिक् (१०) एवं १८; तथा अर्क (१२), पुनन (१४) एवं वेद (४) लिखने से उभयपार्श्विक यंत्र बन जाता है^{५५} यथा—

१६	६	८
२	१०	१८
१२	१४	४

नोट- सन्दर्भ पृष्ठ ४५४-४५५ में देखें।

- ४) "दिनालय के दक्षिण भाग में रहने वाली सुरसा नाम यक्षिणी के नुरुर के शब्द सुनकर है गर्भवती ! तू शाल्य से निरहित हो जा" इस मंत्र को पढ़कर गर्भिणी के ऊपर पाँच अक्षत तुलसी की फेंके तो स्त्री तत्काल ही गर्भ से मुक्ति हो जाती है।^४
- i) Two extra *mantras* mentioned under the management after descend of fetus by Vagubhāra should be used.
- ii) An oblation reciting the *mantras* "all the ties and special bonds are released, the rays have been emitted by sun, the fetus is now free from all the fears, now do not delay do not delay", should be performed.
- iii) Water treated for seven consecutive times with recitation of "cyavanamantra" should be given to the woman for drinking; after this she should be shown *ubhayatrimśāka-yantra* (the numbers written in 9 columns and total comes to thirty in calculating from any side) i. e. :-

16	6	8
2	10	18
12	14	4

- iv) Unhusked five grains of rice washed with water and treated with *mantra* "an ykṣiṣiṇ named Surasā lives in south of himālaya, hearing the noise of her nūpura (an anklet) O pregnant woman ! you should be free from śālya" should be strewn over the woman, using this she delivers the fetus immediately.
- (३) औषधियों का आयुर्वेद-प्रयोग (Oral medication)

- १) मनुजुङ्ग मूल तथा मधुक (चूर्ण या कल्क) घृत के साथ पीने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है।^{४५}
- Use of powdered roots of *māṇḍūṅga* and *mādhukasī* (in equal quantity) mixed with *ghrita* completes the delivery very comfortably.

विमर्श (Comments)

- आयुर्वेदिक साहित्यों में स्त्री को प्रसव उत्तान शयन की स्थिति में ही वर्णित है, महर्षि चरक ने प्रारम्भिक अवस्था में भूमि में बैठने एवं बाद में पलङ्ग में लेटकर, महर्षि सुश्रुत ने प्रारम्भ से ही भूमि पर उत्तान एवं संकुचित सविश को
१. गर्भसङ्गे तु योनिं धृष्यते कुण्डलीनिर्मोकेण पिण्डीतकेन वा, बन्धनीयाच्च हिरण्यपुष्पीमूलं हस्तपादयोः धारयेत् सुवर्चलां विचरन्ता वा। (सु० सं० शा० १०/११)
२. गर्भसङ्गे तु योनिं धृष्यते कुण्डलीनिर्मोकेन पिण्डीतकेन वा। बन्धनीयाच्च हिरण्यपुष्पीमूलं हस्तपादे। धारयेच्च सुवर्चलां विचरन्ता वा। (अ० सं० शा० ३/३)
३. धृष्यतेद्वार्भसङ्गे तु योनिं कुण्डलीनिकच्छेदैः। हिरण्यपुष्पीमूलं च पाणिपादेन धारयेत्॥ ८३॥ सुवर्चलां विचरन्तां वा। (अ० ह० शा० १/८३, ८४)

क्रमशः

प्रसव-विज्ञानीय

स्थिति में लेटकर तथा वागपट ने प्रारम्भ में भूमि में तलश्चाल पलङ्ग में सुश्रुतेक स्थिति में ही प्रसव होने का विधान दिया है। आयुर्वेदिक काल में भी प्रसव की प्रारम्भिक अवस्था में बैठने-या घूमने का निषेध नहीं है अतः वास्तव में सभी आचार्यों के वर्णन में कोई विशिष्ट मतभेद नहीं है। महर्षि चरक ने स्त्री को बैठकर प्रसव करने का निर्देश दिया है जिसका स्मृतिरण कटिन है क्योंकि कारण के काल में उत्तान-स्थिति में प्रसव-व्यवस्था प्रचलित थी।

अष्टाङ्गसंहिता ने चर्मच्छद बिछाने को लिखा है जो आजकल प्रयुक्त मैकिन्टॉश का प्रारम्भिक स्वरूप है एवं गर्भाकटि से आस्तरेण को सुरक्षा के लिए ही सम्भवतः वर्णित है।

सभी आचार्यों द्वारा पुराण फल के धारण का निर्देश, महर्षि सुश्रुत द्वारा कुमारों से घिरा हुई स्त्री का सूतिकागार-प्रवेशादि उस काल की सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुमान् पुत्र ही अधिक वांछित थे, के धोतक हैं। प्रजनन कुशल स्थियों के द्वारा पुत्र-जन्म की घोषणा तथा प्रसवार्थ प्रवाहण के लिए प्रोत्साहन प्रजायिनी को मानसिक रूप से उत्साहित करने के लिए किए जाते होंगे क्योंकि यह प्रमाणित तथ्य है कि स्त्री की मानसिक अवस्था का प्रसव वेदनाओं में प्रभाव पड़ता है।

आवी की उत्पत्ति के बाद भी प्रसव न होने पर गर्भ को अवाक् लाने के लिए महर्षि चरक द्वारा वर्णित औषधियाँ सम्भवतः गर्भाशय की संकोचन-शक्ति को बढ़ाकर गर्भ को प्रसवित करने में सहायता करती हों। महर्षि वागपट द्वारा इन्हें औषधियों का सामान्य प्रसव में प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनावश्यक औषधि-प्रयोग से गर्भाशय-संकोचणी अत्यधिक उत्तेजित हो प्रसव में बाधक भी हो सकती है। जैसा पूर्ववर्णित है गर्भ का अवाक् होना प्रसव की द्वितीयावस्था क्रमशः

४. प्रसवस्य विमर्शे तु धृष्यतेद्विभौ भगम्। कुण्डलीनिर्मोकेण पिण्डीतकेन वा।
तनुना लाङ्गलीमूलं बन्धनीयास्तपादयोः। सुवर्चलां विचरन्तां वा धारयेदधु सूक्ष्मे ॥
कुण्डला वचा चापि जलेन पिष्टा, सैरपडौला खलु नाभिलेपात् ॥
सुखप्रसूतिं कुलेऽङ्गनाम्, निमीडितानां बहुभिः प्रमादैः ॥
मातुलुङ्गस्य मूलं तु मधुकैः संयुतं तथा। घृतेन सहितं पीत्वा सुखं नारी प्रसूयते ॥
इक्षोलेतमूलं निजतनुमानेन तनुना बद्ध्वा। कटिविषये गर्भवती सुधेन स्वेऽविलम्बितेनापि ॥
तलस्य चोर्ध्वं मूलं स्वप्रमाणेन तनुना। बद्ध्वा कट्यां तु नियतं सुखं नारी प्रसूयते ॥
प्रत्यकुष्ठ्याः पार्श्वप्रस्य यद्गमूलं यद्वा काकबन्धसमुत्थम्।
कट्यां बद्धं योषितं सम्प्रसूतिं यो युक्या सहतं साधु कुर्यात् ॥
इहामृतं..... निवसन्तु ये। इदममृतमयं.....विमृष्टुशान्तिम् ॥ (अ० सं० सदृश पु० ४५०, ४५१)
मुकाः पाशा विपाशाश्च मुकाः सूर्येण तप्यतः। मुक्तः सर्वभयादगमं एहि मा विर मा विरम् स्वहा ॥
जलं च्यावनमनेण ससवाताभिमन्त्रितम्। पीत्वा प्रसूयते नारी दृष्ट्वा चोपयंत्रिकम् ॥
कलारसाधभिः पक्षदिगाद्यदशभिः क्रमात्। अकैश्च भुवनैर्वैरभयत्रिकं भवेत् ॥
हिमवदक्षिणे पार्श्वे सुरसा नाम यक्षिणी। तस्य मुसुराब्देन विशाला भव गर्भिणी ॥
इमं स्त्रोके पठित्वा तु क्षिपेत्क्षतपञ्चकम्। गर्भपुष्टिर्न सद्यः सा गर्भं मुञ्चति गर्भिणी ॥
५. प्रसवस्य धारयेदधु सूक्ष्मे ॥ १०५-१०६॥ (यो० १० सदृश)
कङ्क्रीभृत गोमूर्द्धा सूतिकाभवगोपरी। स्थापितस्तक्षणागार्याः सुखं प्रसवकारकः ॥ १०७॥
(कङ्क्रीभृत-अस्थिमार्जेण स्थितः.....)।
पलोकामूलकत्वेन तिलतैलयुतेन च। योनेरभ्यन्तं लिप्त्वा सुखं नारी प्रसूयते ॥ १०८॥
कुण्डलवचा..... प्रमादैः ॥ १०९॥ मातुलुङ्गस्य मधुकेन युतं प्रसूयते ॥ ११०॥
इक्षोलेत..... स्वेऽविलम्बितेन ॥ १११॥ तलस्य..... कट्यां तु ॥ ११२॥ (यो० १० सदृश ही)

का द्योतक है अतः यह मान सकते हैं कि गर्भ को अवाकू लाने के लिए वर्णित विधियाँ द्वितीयावस्था के प्रारम्भ में उत्पन्न प्रसव-अवरोध के निराकरण के लिए हैं। महर्षि सुश्रुत तथा परवर्ती भावमिश्र एवं योगरत्नाकर ने केवल गर्भसङ्क (यूटीरिन इनऱयें) की चिकित्सा का उल्लेख किया है जो विधि प्रसव की द्वितीयावस्था में गर्भाशय-संकोच बढ़ाने के लिए वर्णित है परन्तु चूँकि महर्षि वाग्भट ने गर्भ के अवाकू हो जाने के पश्चात् गर्भसङ्क-चिकित्सा का वर्णन किया है अतः यह मान सकते हैं कि यह चिकित्सा प्रसव की द्वितीयावस्था के अन्तिम चरण की है। महर्षि चक्रादि वर्णित प्रसव मन्त्रों का महर्षि सुश्रुत ने मूढगर्भ की चिकित्सा में उल्लेख किया है जिसका कारण सम्भवतः महर्षि सुश्रुत द्वारा गर्भ के प्रसव न होने की स्थिति को मूढगर्भ माना जाना है।

आधुनिक काल में प्रचलित योनि-प्रसारण की विधि का स्पष्ट उल्लेख महर्षि वाग्भट ने किया है। प्रवाहण विधि के लिए शिक्षा बहुत ही वैज्ञानिक है क्योंकि अकाल में व्यर्थ ही प्रवाहण करने से स्त्री की शक्ति-ह्रास होने से सम्भव है कि उचित काल में वह प्रवाहण न कर सके अथवा अत्यधिक थक जाने के कारण उसे गर्भाशय-संकोच होना (यूटीरिन इनऱयें) हो जाय। अकाल प्रवाहणोत्तर शिशु-विकार का स्पष्टीकरण कठिन है। यह सम्भव है कि तीव्र प्रवाहण से या तो गर्भ अतिशीघ्र प्रसवित हो जाय या गर्भाशय-संकोच-होना हो जाय, दोनों ही स्थितियों में गर्भ पर प्रभाव पड़ कर उसे विभिन्न व्याधियाँ हो जाती हों।

मन्त्र-चिकित्सा एक वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय है। प्रसव के अवरोध में मन्त्र-प्रयोग सम्भवतः स्त्री को मानसिक रूप से प्रभावित कर हार्मोनलमस द्वारा पश्चिम पीयूषाश्रयि के साथ को उत्तेजित कर प्रसव में सहायक होते हों।

The position of parturient woman i.e. supine with flexed thighs described in *āyurvedika* classics resembles with Sim's position used today. Though Caraka has advised initial squatting position, however, before delivery the woman was made to lie down. During first stage sitting or walking is beneficial in bringing down the fetus and also in distracting her attention from the labour pains. Caraka's and Vāgbhata's description of conduction of labour on the bed is a better procedure than Suśruta's description of conduction of labour on floor. Why Kāśyapa has advised squatting position is difficult to explain, because by that time lying position was prevalent. Use of skin over the bed by Vāgbhata is probably first description of mackintosh.

Holding fruits bearing masculine names by the woman at the beginning of labour pains, initial encirclement by male adolescents etc. hint towards the social condition prevailing at that time, where-in male children were more wanted. Pronouncement of delivery of a male child and other encouragements to bear down were probably used to boost the morale of parturient woman, because it is established fact that psychology of woman plays very important role during labour.

Drugs prescribed by Caraka to bring down the fetus (which has failed to come down inspite of presence of labour pains) probably stimulate the uterine musculature and improve the expulsive efforts, however, their routine use described by Vāgbhata is not justified, because over-stimulation to normally functioning uterine muscles can cause certain complications. As explained earlier that descend of fetus is indicative of second stage of labour, the treatment prescribed by Caraka before the descend of fetus is to stimulate the uterus in the beginning of second stage. *Garbhasaṅga* (uterine inertia) described by Suśruta etc. is an abnormality of second stage of labour, however, since Vāgbhata has described *garbhasaṅga*

after descend of fetus, thus it may be considered as the treatment during latter period of second stage. Suśruta has described *mantras* in the treatment of obstructed labour (*manthagarbha*).

Dilatation of vaginal canal or ironing described by Vāgbhata is practised even today. The education regarding bearing down efforts is very important, because undue straining by woman may exhaust her and lead to uterine inertia. It is difficult to explain specific diseases to the child developing due to undue straining; it is possible that delayed or precipitate both labours may injure the child and produce certain abnormalities.

Use of *mantras* is a subject of scientific investigations, however, it is possible that these might influence posterior pituitary via hypothalamus thus increase amount of posterior pituitary extract which in turn effects uterine contractions.

अपरा पतन (Placental expulsion)

(अ) स्वाभाविक अपरा-पतन (Normal expulsion of placenta)

गर्भ-प्रसव के पश्चात् अपरा-पतन का वर्णन सभी आचार्यों ने किया है परन्तु स्पष्टतः उल्लेख महर्षि चक्रादि एवं काश्यप ने दिया है। महर्षि चक्रा ने लिखा है कि जब प्रसव हो जाय तो कोई स्त्री (परिचारिकाओं में से एक) ध्यान से देखे कि अपरा बाहर आ गई या नहीं। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने प्राकृतिक प्रसव की परिभाषा में अवाकू-शिर गर्भ-प्रसव के पश्चात् मधु-हृदय से च्युत अपरा-निर्गमन ही प्रकृति एवं अन्य विकृति माना है। महर्षि काश्यप ने भी अपरा-निर्गमन के पश्चात् ही उसे सूतिका वर्णित किया है।^१

Though expulsion of placenta has been mentioned in all the classics, however, distinct description has been given only by Caraka. Vāgbhata and Kāśyapa. Caraka says that after delivery of fetus one of the attendants must inspect carefully that whether placenta is expelled or not. Vāgbhata I defining normal labour says that delivery of fetus in vertex presentation followed by expulsion of placenta (detached from *mātrī-hṛdaya*) is normalcy, all other conditions are abnormal. Kāśyapa says that without expulsion of placenta, the woman can not be termed as puerperal woman.

आ) अपरा पतन न होने पर उपद्रव (Complications of retention of placenta)

अपरां हि वातुमुपरोषापायन्यानि चान्तर्बहिर्माणाणि सञ्जन्ति ॥ (च० सं० शा० ८/४९)

अथपरापतन्त्यानाहोभ्यानौ कुरुते । (सु० सं० शा० १०/२९)

अपरा (न निकली हुई अपरा) वात, मूत्र, पुरीषादि सभी बहिर्माणों से निकलने वाले (मलों) को अन्दर रोक देती है। टीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है कि बहिर्माणशील पुरीषादि आप्मन्त्र प्रदेश (कोष्ठान्तर्गत) में संसक्त हो जाते हैं।^४

१. यदा च प्रज्जला स्यात्तद्देहनामवेक्षेत-काचिदस्मा अपरा प्रज्जा न वेति ॥ (च० सं० शा० ८/४९)
२. अ० सं० शा० २/३५ (पृष्ठ ४३४)
३. का० सं० शिख० ११/६ (पृष्ठ ४३९)
४. अन्तर्बहिर्माणानि सञ्जन्तीति बहिर्माणशीलानि पुरीषादीनि, अन्तः आप्मन्त्रदेशे संसक्तानि भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ८/४९ चक्रपाणि टीका)

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि न गिरी हुई अपरा आनाह एवं आप्मान उत्पन्न करती है। भ्रूविमिश्र एवं योगान्ताकारकार ने लिखा है कि यदि प्रसूता स्त्री के चउर से अपरा नहीं पतित होती तो वह शूल, आप्मान तथा अग्निमान्द्य कर देती है^१।

Retained placenta obstructs the passage of flatus, feces and urine etc. excreted through external orifices.

Suśruta has enlisted *ānāha* (tympanties) and *āthmāna* (flatulence) and *Bhāvaprakāśa* and *Yogaratnākara* pain (colic), flatulence and anorexia as complications of retained placenta.

अपरा की पालन-विधि (Treatment of retention of placenta)

महर्षि सुश्रुत ने अपरा-पालन विधि का दो स्थानों में वर्णन दिया है (१) शरीर स्थान (२) चिकित्सा स्थान (पूजापर्व-चिकित्सा)। चौक दोनों ही स्थानों में वर्णित विधि में कोई विशिष्ट सैद्धांतिक अन्तर नहीं है अतः एक ही स्थान पर (यहीं) उल्लेख किया जा रहा है।

Suśruta has described this subject at two places, both references are recapitulated here.

चिकित्सा सिद्धान्त (Principles of Treatment)

तत्सङ्गे ह्यनिलोहेतुः सा निर्यात्याशु तज्ज्यात् । (अ० ह० शा० १/१०)

अपरासङ्ग का कारण वायु ही होती है अतः उसे विजय कर लेने या शान्त कर लेने से अपरा तुरंत ही निकल जाती है। Viation of vāyu is main etiological factor for retention of placenta, with its suppression placenta comes out immediately.

बाह्य उपचार (External manipulations for placental expulsion)

- १) दक्षिण हस्त से (प्रसूता की) नाभि के ऊपर बलपूर्वक दबाकर बायें हाथ से पीठ को पकड़कर (तीव्र रूप से) हिलावे^{१,३} उसकी बाहुओं को ऊपर उठाकर उसे खूब कपाये या हिलावे^४।
- २) नाभि से श्रोणि (प्रसूता की) को कूटें अर्थात् बार-बार दबाव डालें^{१,३,४}।
- ३) दोनों भुजाओं को पकड़कर भली भाँति या कस कर दबावे^{३,४,५}।
- ४) बालों को वेणी^{१,३,४} अथवा बाल लिपटी हुई उंगली^{३,४,५} से कण्ठ एवं तालु का स्पर्श करें।
- ५) स्त्री की योनि को तैलाक्त कर पश्चात् उसके पार्श्वों को पीड़न कर एवं उसे बार-बार हिलाकर अथवा अंसपिण्डका की तरह पीड़न करके अपरा का पालन करावे^१।
- i) Compressing forcefully the abdomen of delivered woman over umbilicus and holding her by back, she should be waggled violently or else holding her by both the arms violent jerks should be given.
- ii) The attendant should strike or compress repeatedly the pelvis of delivered woman by her heels.
- iii) Holding her by both the hips, violent compression should be done.

१. प्रसूताया न पतित जठरापरा यदि । तत्र सा कुले शूलमाप्यात् वह्निमन्त्रताम्॥

(पा० प्र० वि० ७०/१३१ एवं यो० १०. स्त्रीरोग चि०)

नोट- सम्पूर्ण चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ४६३-४६४ में देखें।

- iv) Throat (inside) and palate should be touched with braid of hair or a finger wrapped with hair.
- v) After oleating the vagina properly and compressing her flanks she should be given violent jerks or else it (uterus) should be compressed just like shoulder and placenta delivered.

बाह्य औषधि-प्रयोग (External use of drugs to expell the placenta)

अ) योनि में धूपन (Fumigation in vagina)

निम्नाङ्कित औषधियों से योनि का धूपन करें।

- १) भोजपत्र, काचमणि एवं सर्प-निर्मोक^{१,३,४}।
 - २) भोजपत्र एवं गुग्गुलु^१।
 - ३) शालिमूल-साधित घृत से योनि का अपघ्न कर के कटुकालाबु, जालिनी, निम्ब एवं सर्प-निर्मोक^३।
 - ४) कटुकालाबु, कृतवेधन, सर्पप एवं सर्प-निर्मोक अथवा केवल सर्प-निर्मोक को कड़वे तैल में मिलाकर^{३,४}।
 - ५) भूर्ज, लाङ्गलिकी, तुम्बी, सर्पचक्र, कुष्ठ एवं सर्प सभो से पुष्पक पुष्पक, दो-दो अथवा सभी को मिलाकर^४।
- Vaginal fumigation with following drugs should be done.

- i) *bhūjapātra*, *kācamani* and slough of snake.
 - ii) *bhūjapātra* and *guggulu*.
 - iii) After massaging the vagina with *śālimālī ghṛta* fumigation with *kaiukālābhu*, *jālīnī* (bottle and ridge-gourd), *nimba* and slough of snake.
 - iv) *Kaiukālābhu*, *kṛtavedhana*, *sarṣapa* and slough of snake or only slough of snake mixed with mustard oil.
 - v) *Bhūjapātra*, *lāṅgālīkī*, *tumbī*, slough of snake, *kusūha* and *sarṣapa* either all together or two of them or individually.
- (आ) योनि में लेपन या पूरण (Anointment or filling in vagina)
- निम्नाङ्कित औषधियों का योनि में लेपन या पूरण करें।
- १) कटुकालाबु, जालिनी, निम्ब एवं सर्प-निर्मोक के कल्क को कड़वे तैल में मिलाकर (योनि को) तैलाक्त करके लेप करें^३।
 - २) गुड़ एवं शुण्ठी के कल्क का लेप करें^३।
 - ३) उमा तथा शाल्मली-निर्वास को घी के साथ मिलाकर योनि में पूरण कर (स्त्री को) हिलावे (झिझकोरे)^३।
 - ४) योनि धूपनान्तर्गत न० ५ की वर्णित औषधियों से लेपन करें^४।
- Paste of following drugs should be applied in vaginal canal :
- i) Paste of *kaiukālābhu* (bitter bottle-gourd) and *jālīnī* (ridged-gourd), *nimba* and slough of snake mixed with mustard oil after initial application of oil in vagina.

नोट- सन्दर्भ पृष्ठ ४६३-४६४ में देखें।

- ii) Paste of jaggery and *śunthi*.
- iii) *Uṇā* and gum of *śālmālī* mixed with *gūḥra* should be filled in vagina and violent jerks be given.

iv) Paste of drugs prescribed under column V of vaginal fumigation.

(इ) अन्य अङ्गों में लेपन या अनुसेवन (Anointment or irrigation over other body-parts)

- १) लाङ्गलीमूल-कल्क को हाथों एवं उदर^{३,५,६} अथवा हाथ-पैर में लेप^{३,५,६} करें।
- २) महावृक्ष (सेहण्ड) के क्षीर को मूर्च्छा (शिर) में अवसेवन^{३,३,४} करें।
- ३) हिरण्यगोमूल, सुवर्चला तथा विशल्या का हाथ या पैर में धारण करें^४।
- ४) निमोक्त, कटकालाबु, कृतवेधन एवं सर्षप (कल्क) का हाथ या पैर में लेपन करें^१।
- i) Paste of *lāṅgālī* should be applied over palms and abdomen or palms and soles.
- ii) Irrigation with latex of *mahāvṛkṣa* over head.
- iii) Amulet of root of *hiraṇyapuspī*, *suvarcalā* and *viśalyā* in arm or leg.
- iv) Pested slough of snake, *kaṭukālābhu*, *kṛtavedhana* and *sarṣapa* should be applied over palms and soles.

ई) योनि में पिचु-धारण (Vaginal tampons)

- १) शतपुष्पा, कुष्ठ, मदनफल तथा हिंगु से साधित तैल की पिचु धारण करें^{१,३}।
- i) Tampon soaked with oil prepared with *śatapuspā*, *kusṣha*, *madanphala* and *hingū* should be given.

ए) बस्ति-प्रयोग (Use basti to expell the placenta)

- १) अनुवासन बस्ति (*Anuvāsana-basti* i.e. *unctuous enema*)
- १) पिचु के अन्तर्गत वर्णित तैल से अनुवासन बस्ति दें^{१,३}।
- २) शिशु, सुमूख, मरिच, अजगिज एवं चित्रक के कल्क तथा क्षीर (गोदुध) एवं गोमूत्र से साधित कटु तैल की अनुवासन बस्ति दें^३।
- ३) उत्तरबस्ति के अन्तर्गत वर्णित नः३ के तैल से गुदा में अनुवासन बस्ति भी देनी चाहिए^४।

Following preparations should be used in the form of *anuvāsana basti* i.e. *unctuous or retention enema* :—

- i) *Śatapuspādī* oil prescribed for tampon.
- ii) Mustard oil prepared with pated *śigru*, *sumukha*, *marica*, *ajāji* and *citraka* alongwith cow's milk and urine.
- iii) Oil prescribed in column (iii) of *uttarabasti*.

२) आस्थापन बस्ति (*Āsthāpana basti* i.e. *cleansing enema*)

१. इन्हीं आस्थापन द्रव्यों (बल्वन क्वाथ या सैर्य एवं सुरामण्ड या कुलत्थ क्वाथ या मण्डूकपर्णी एवं पिप्पली नोट- सन्दर्भ पृष्ठ ४६३-४६४ में देखें)।

क्वाथ में) फल, जीमूतक (देवदारो या मुस्त ?), इक्षुक्कु, धामार्गव, कुटज, कृतवेधन एवं हस्तिपिप्पली मिलाकर आस्थापन बस्ति दें^१।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने इन सभी औषधियों के साथ विल्व एवं अर्क का तथा हस्तिपिप्पली के स्थान में हस्तिपर्णी का वर्णन दिया है^१।

२) सिद्धार्थक, कुष्ठ, लाङ्गली (मूल) तथा महावृक्ष के क्षीर से मिश्रित सुरामण्ड से आस्थापन बस्ति दें^{३,३}।

३) शास्मली-वृत्त को अच्छी प्रकार स्थित करके (उबालकर) पञ्चमूल कषाय में मर्दन करके, छानकर फलादि (न० १ में वर्णित) द्रव्य एवं स्नेह को भलीभाँति मिलाकर (आस्थापन दें)^३।

४) शतपुष्पा, वचा, कुष्ठ, कणा एवं सर्षप के कल्क में स्नेह एवं लवण मिलाकर निरुह बस्ति देने से अपरा शीघ्र ही निकल जाती है^४।

Following preparations should be used in the form of *āsthāpana basti* i.e. *cleansing enema* for placental expulsion :—

- i) Decoction of *phala*, *jīmūṭaka*, *ekṣvāka*, *dhamārgava*, *kuṇja*, *kṛtavedhana* and *hasṭipipālī* or *hasṭiparjī* and *arka* mixed with either decoction of *balwaja* or *bliva* and *balwaja* or *maireya* (a kind of intoxicating drink) and *surāmanāḍa* (the froth or scum of spirituous liquor or beer) or decoction of *kulātha* or *mandūkaperjī* and *pīppalī*.

ii) Pested or powdered *śiddhāṛthaka*, *kusṣha*, *lāṅgālī* and latex of *mahāvṛkṣa* mixed with *surāmanāḍa*.

iii) Properly steamed twigs of *śālmālī* should be pested with decoction of *pañcamūla* and strained, this filtrate mixed with *phala* etc. drugs mentioned above in no. 1 and fat (oil).

iv) Paste of *śatapuspā*, *vaca*, *kusṣha*, *kaṇā* and *sarṣapa* mixed with fat (oil) and salt.

आस्थापन बस्ति की कार्य-विधि (*Mode of action of āsthāpana basti*)

इस आस्थापन बस्ति से वायु के अप्रतिलोम (अनुलोम) हो जाने से वात, मूत्र एवं पुरीष के साथ चित्रकी हुई अपरा निकल जाती है^१।

Due to *anulomana* (downwards movement) of *vāyu* (*apāna vāyu*) by use of this *āsthāpana basti*, along with flatus, feces and urine adhered placenta also comes out.

३) उत्तरबस्ति (*Uttarabasti* i.e. *vaginal / uterine injection*)

१) सिद्धार्थकादि (सिद्धार्थक, कुष्ठ, लाङ्गली, महावृक्ष-क्षीर आदि आस्थापनान्तर्गत वर्णित) से साधित तैल की उत्तरबस्ति दें^३।

२) फल, जीमूतकादि आस्थापनान्तर्गत न० १ में वर्णित द्रव्यों से साधित कटुतैल की उत्तरबस्ति दें^३।

३) शलाह्ला, सर्षप, अजगिज, शिशु, लोक्षक, चित्रक, हिङ्गु, कुष्ठ, मदनफल तथा मूत्र एवं क्षीर (गोमूत्र तथा गोक्षीर) से सिद्ध सरसों के तैल से योनि में बस्ति देनी चाहिए^१।

Uttarabasti (irrigation/instillation of drugs in vaginal canal or uterine cavity) of following preparations should be given in cases of retention of placenta.

नोट- सन्दर्भ पृष्ठ ४६३-४६४ में देखें।

- i) Oil prepared with *siddhānīrthaka*, *kuṣṭha*, *lāngulī* and latex of *mahāvīrkṣa*.
- ii) Mustard oil treated with *phala* etc. drugs described under column one of *āśhīpāna* *baśi*.
- iii) Vaginal douching with mustard oil prepared with pestled *śālāhwa*, *sarsapa*, *ajāṭi*, *śīgṛa*, *tikṣṇaka*, *citraka*, *hingu*, *kuṣṭha*, and *madanaphala* along with cow's urine and milk.

आयन्तर औषधि-प्रयोग (Oral medication for expulsion of placenta)

- १) गुड़ एवं शुण्ठी का कल्क खाने को दें^१।
- २) कुष्ठ एवं तालीस (पत्र) के कल्क को बल्लज के यूस अथवा भैंस^१ एवं तीक्ष्ण सुरामण्ड अथवा कुलस्थ-यूस^१ अथवा मण्डूकपर्णी एवं पिप्पली के कषाय के साथ मिलाकर पीने को दें^{१,४}।
- अष्टाङ्गसंहकार ने कुष्ठ एवं तालीस के कल्क को चरक-वर्णित औषधियों के साथ ही बिल्व-कषाय अथवा आसव अथवा व्योष के द्वारा तीक्ष्ण करके अथवा अम्ल (कौजी) के साथ पी देने एवं मण्डूकपर्णी के स्थान में मधुयष्टी का वर्णन दिया है। टीकाकार इन्द्र ने मधूक अर्थात् महुआ लिखा है तथा कुष्ठ एवं तालीस के कल्क का विभिन्न द्रव्यों के साथ प्रयोग दोषादि के आधार पर तथा मवाद का प्रयोग देह-प्रकृति के आधार पर करने का निर्देश दिया है^१।
- ३) सूक्ष्मैला, किलिम, कुष्ठ, नागर, विडङ्ग, पिप्पली, कालागुरु, चव्य, चित्रक एवं उपकुञ्जिका के कल्क^१ अथवा जीवित खारवष^१ (चण्डबलीवर्द या सौंड) अथवा खर (गधा) एवं वृषभ^१ के दक्षिण कर्ण को काटकर पत्थर में जबर करके बल्लज कषाय^१ अथवा बिल्व-बल्लज कषाय^१ आदि (अपुर्तक नं० दो के अन्तर्गत वर्णित अन्य औषधियों) में से किसी एक में घोलकर एक मुहुर्त रखकर (ऊपर के द्रवभागा को) निकालकर उस द्रव को पीने को दें^{१,३}।
- ४) कुष्ठ एवं लाङ्गली-मूल के कल्क को मद्य या मूत्र के साथ पीने को दें^{१,३}।
- ५) शालमूल अथवा पिप्पल्यादिपण के कल्क को मद्य के साथ पीने को दें^३।
- ६) पिप्पली, एला, कोल, विड (विड नमक), चव्य, चित्रक एवं उपकुञ्जिका के कल्क को दें^१।
- ७) कुष्ठ एवं एला के कल्क को सुरा के साथ दें^३।
- ८) अर्क (रक्त-मदार) एवं अलर्क (श्वेत-मदार) के कषाय को सुरा मिश्रित करके पीने को दें^१।
- ९) वत्सकादि चूर्ण को मद्य के साथ दें^१।
- i) Paste of jagugery and *śunīhī* should be given for eating.
- ii) Paste of *kuṣṭha* and *tālispāra* mixed with either decoction of *balwaja* or *maireya* and strong *surāmanā* or decoction of either *kulārtha* or *maṇḍūkāparṇī* and *pippalī* or *biḥva* or *maḍhūyaṣā* and *pippalī* or *madhūka* and *pippalī* or *āsawa* or powdered *vyoṣa* or *kāñjī* (sour fermented drink) should be given. Indu has explained that various decoctions etc. should be prescribed with paste of *kuṣṭha* and *tālisa* considering the valuation of *doṣas*, while wine preparations should be given on the basis of *daihiḥka* *prakṛti* (physical constitution) of the woman.

iii) Either paste of small *ela*, *kilima*, *kuṣṭha*, *nāgura*, *viḍāṅga*, *pippalī*, *kālāgura*,

नोट- सत्यं पृष्ठ ४६३-४६४ में देखें।

cavya, *citraka*, and *upakūñcika* or right ear of alive strong bull or donkey and bull both crushed properly with stone should be mixed with any one out of decoctions of *balwaja* or *biḥva* etc. described above in no. ii. After keeping this for one *muhūrta* (fortyeight minutes) supernatant fluid should be given to drink.

- iv) Paste of *kuṣṭha* and root of *lāngulī* should be given with either urine (cow's) or wine.
- v) Paste of root of *śāla* or *pippalyādi* group of drugs should be given with wine.
- vi) Paste of *pippalī*, *ela*, *kola*, *viḍ* salt, *cavya*, *citraka* and *upakūñcika* should be given.
- vii) Paste of *kuṣṭha* and *ela* should be given with wine.
- viii) Decoction of *arka* and *alarka* (red and white varieties of *arka*) mixed with wine should be given.
- ix) Powder of *vasakādi* group of drugs mixed with wine should be given.

अपरा का हस्त-निष्काशन (Manual removal of placenta)

(उपपुर्तक सभी विधियाँ असफल हो जाने पर ही यह विधि अपनानी चाहिए)।
कटे हुए नाबून वाले स्निग्ध^{३,४,५,६} हाथ से नाल का अनुसरण करते हुए^१ (हाथ को अन्दर प्रविष्ट करके) अपहरण करें।

If all above drugs/methods fail, then this method should be used. Lubricated hand having nails already trimmed should be inserted following umbilical cord and placenta delivered.

१. तत्साक्षेदपरा न प्रपञ्च स्यादधैर्यामन्यतम स्त्री दक्षिणेन पाणिना नाभेरपरिष्ठादलवत्रिणीज्य सत्येन पाणिना पृष्ठत उपसंगृह्य तां सुनिर्धृतं निर्धुन्यात्। अथास्याः पाण्या श्रोणिपाकोटयेत्। अस्याः फिकावातुसंगृह्य सुपीडितं पीडयेत्। अथास्यां बालवेण्या कावतालु परितुशेत्। भूर्जपत्रकाचमणिसर्पिर्मौकेध्यास्या योनिं धूयेत्। कुष्ठतालीसकल्क बल्लजयूस भैंससुरामण्ड तीक्ष्णे कौलस्थे वा यूषे मण्डूकपर्णीपिप्पलीसंपाके वा सखाज्य पायदेदेनाम्। तथा सूक्ष्मैलाकिलिमकुष्ठनागारविडङ्गपिप्पलीकालागुरु-चव्यचित्रकोपकुञ्जिकाकल्क खारवषभस्य वा जीवितो दक्षिण कर्णमुकृत्य दूषदि ज्वरीकृत्य बल्लजकषायादीनामापदानाना-नामन्यतमे प्रक्षिप्याख्याज्य मुहुर्तीस्थितमुदधृत्य तदालावनं पायदेदेनाम् शतपुष्पाकुष्ठमदन्दिङ्गुसिद्धस्य चैनां तैलस्य पित्तुं ग्राहयेत्। अतश्चैवानुवसयेत्। एतैव चालावयैः फलजीमूतेश्वाकुषागाविकुटजकवलेषमहसितीपपत्त्युपरिहरेत्तस्यायेत्। ततस्त्यापनमस्याः सह वातमूत्रपुरीषैर्निर्हृत्यपरमासकां वायोरेवाप्रतिलोमान्यात्। (खारवषभश्छाडकलीवर्दः चक्र०)

(च० सं० शा० ८/४१)

२. अ) तस्मात् कष्टमस्याः केचोद्धितयाङ्गुल्या प्रमुञ्चेत्, कटुकालावुकुलवेषनसर्पसर्पिर्नमौकेर्वा कटुतैलविमिश्रयौनिमुखं धूयेत्, लाङ्गलीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणिपादतलमालिम्पेत्, मूर्ध्नि वाऽस्याः महावृक्षशीरानुवसेयेत्, कुष्ठलाङ्गलीमूलकल्कं वा मद्यमूत्रोरन्यतरेण पायदेत्, शालमूलकल्कं वा पिप्पल्यादि वा मद्येन, सिद्धार्थककुष्ठलाङ्गलीमहावृक्षशीरमिश्रेण सुरामण्डेन वाऽऽस्यायेत्, एतैव सिद्धेन सिद्धार्थकतैलेनोत्तरवर्तिं दद्यात्, स्निग्धेन वा कृत्तनखेन हस्तग्राहयेत् ॥

(सु० सं० शा० १०/११)

आ) अथपतन्तीमपतं पातयेत् पूर्ववत् पिप्पल्। हस्तेनपहरेत् वाऽपि पार्श्वान् परिपीड्य वा ॥

धुतुयञ्च मुहूर्तं पीडयेद्दोऽसपिडकाम्। तैलाकयोरेव तां पातयेन्मतिमभिषक् ॥ (सु० सं० चि० १५/१७, १८)
३. अथ प्रसूतया न चेटया पतति ततो दक्षिणेन पाणिना नाभेरपरिष्ठादलवदुपरीज्य पृष्ठत उपसंगृह्य विधुन्यात् (१)।

क्रमशः

विमर्श (Comments)

अपरा के पातन के लिए उपर्युक्त वर्णित विधियों को क्रियाकलाप की दृष्टि से चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिनमें पहिली को छोड़कर अन्य सभी विधियाँ ही सिद्धान्तः आज भी प्रयुक्त होती हैं।

On the basis of mode of action all above drugs/methods can be classified under four groups. Except no. 1 other methods are practised in principle even to-day.

क्रमशः

पाण्ड्या ना श्रीणिमाकुट्टयेत्। स्किन्नी वोपसंहरा सुपीडितं पीडयेत्। वेण्याङ्गुल्या वा केजवेष्टिण्या च कण्ठलातु पापयेत् (२)।

पूर्वपञ्चकाचमणिसर्पिन्मकेश्वर्योर्ध्वपायेत्, पूर्वगुणुगुण्यां वा। शालिमूलसिद्धेन वा सर्पिणा योनिमध्यञ्च कटुकालातुवा-
तिनीमिन्नसर्पिन्मकेश्वर्योर्ध्वपायेत्। अनप्यत्तां वा कटुतैलाभिः कल्कीकृत्वा तैलाकैरालिम्पेत्। गुडगारकत्केन वा। तदेव वा भक्षयेत्। लाङ्गलीमूलकत्केन वा पाणिमुदं चालिम्पेत्। महावृक्षैश्च वा मूर्धन्यन्वयेचयेत् (३)।

कुष्ठलातीसकल्कं विस्त्रवत्स्त्रजम्भैर्याससुतामण्डान्तमेन व्योतीक्ष्योन्नेन वाऽस्तेन कुल्लरसेन मधुकपिपलीसंघकेन वा पायेत्। पिण्डलेताकोतिविडम्ब्यवित्रकोपकुष्ठिका कल्कं वा। खरस्य वृषभस्य वा जीवतो दक्षिणं कर्ममुदधृत्य विस्त्रकुल्लजम्भैर्यादीनामास्त्रानामान्यतमे प्रक्षिप्य मुहूर्तिभ्यतमुदधृत्य तदारुचनं पायेत् (४)।

कुष्ठैलसकल्कं वा सुर्या। अर्कालककायं वा सुर्यामिश्रम्। कुष्ठलाङ्गलीकोमूलकल्कं वा मध्वान्नान्तरेण। वत्सकादिचूर्णं वा महेन। शतपुष्पाकुष्ठमन्दहिङ्गुसिद्धस्य च तैलस्य पित्तुं ग्राहयेत्। तत्क्षैनामनुवासनकालेऽनुवासयेत् (५)।

विस्त्रवत्स्त्रजम्भैर्यादीनामास्त्रानामान्यतमे प्रक्षिप्य मुहूर्तिभ्यतमुदधृत्य तदारुचनं पायेत् (४)।

कुष्ठलाङ्गलीकोमूलकल्कं वा सुर्यामिश्रम्। कुष्ठलाङ्गलीकोमूलकल्कं वा मध्वान्नान्तरेण। वत्सकादिचूर्णं वा महेन। शतपुष्पाकुष्ठमन्दहिङ्गुसिद्धस्य च तैलस्य पित्तुं ग्राहयेत्। तत्क्षैनामनुवासनकालेऽनुवासयेत् (५)।

कृतचन्द्रेण पाणिना नालानुसारतोऽपहरेत् (७)।
(दोषाद्यपेक्षया कुष्ठलातीसयोः कल्कं पायेत्.....मधुकपिपली संघकेन..... प्रकृतिहृदयपेक्षमात्राः सुयोनिमिश्रं पायेत्.....-इन्दु टीका) (अ० सं० शा० ३/३४-९ से ७)

४.पार्श्वसङ्घातानि वर्णितं चिकित्सा एवं-

.....जरायवतरेऽपि च। कायमेतत्तथोक्तस्य चाङ्गैरनां विक्रमयेत् ॥ ८४॥

कटीमाकोटयेत्पाण्ड्या स्किन्नी गाढं निपीडयेत्। तालुकण्ठं स्पृशेत्पा मूर्ध्नि दद्यान्नुहीपयः ॥ ८५॥

शूर्पलाङ्गलीकोमूलकसर्पिन्मकेश्वर्योर्ध्वपायेत्। वृषगद्वाभ्यां समस्तेर्वा योनिलेपनपूणम् ॥ ८६॥

कुष्ठलातीसकल्कं वा सुर्यामिदं पायेत्। यूपेण वा कुल्लरानां विस्त्रवोनासनेन वा ॥ ८७॥

शलाङ्गलातीसकल्कं वा सुर्यामिदं पायेत्। सहिङ्गुकुष्ठमन्दहिङ्गु क्षीरे च साधयेत् ॥ ८८॥

तैलं सिद्धं हितं पायी योन्या वाऽप्यनुवासनम्। शतपुष्पावचाकुष्ठकणासर्पकटिकारः ॥ ८९॥

निरहः पातयत्यायुः सस्तेहलवणोऽप्याम्। तत्सङ्गे ह्यनितो हेतुः सा निरर्त्यायुः तज्यात् ॥ ९०॥

कुशला पाणिनाऽन्नेन हरेत्कुल्लनखेन वा ॥ ९१॥ (अ० ह० शा० १)

५. केसवेष्टितयाङ्गुल्या तस्याः कण्ठं प्रषभयेत्।

निर्मेककटुकालातुङ्गुलजम्भनसर्पः। चूर्णितैः कटुतैलाकैर्धूपयेदभितो भगम् ॥ ९३२॥

लाङ्गलीमूलकत्केन पाणिपादतलानि हि ॥ ९३३॥

प्रतिष्प्रेष्टुमिदं योषिद्व्यापातनाय वै। हस्तं विन्नखं स्निग्धं सूतायोनी रनैः क्षिपेत् ॥ ९३४॥

अपरा तेन हस्तेन जनघाति विनिहरेत् ॥ ९३५॥ (पा० प्र० चि० ७०)

६. केसवेष्टित सर्पः ॥

लाङ्गलीमूल विनिहरेत् ॥ (यो० १० स्त्री० चि०; भा० प्र० सद्गुह्ये ही)

प्रसव-विज्ञानीय

१) उदरगुहान्तर्गत भार-वृद्धि कारक (By increasing intra abdominal pressure)

वेणी से कण्ठ-मार्ग (द्वारा उत्पन्न काम), स्किन्ना दवाना आदि बाह्य उपचार इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

Touching of palate or throat with braid of hair or finger wrapped with hair may produce instantaneous cough thus may suddenly increase intraabdominal pressure. Similarly compression of hips and/or violent jerks may also increase intraabdominal pressure and help in expulsion of placenta.

२) गर्भाशय को संपीडन करके (By compressing the uterus)

सुश्रुतेक अंसपीण्डिका का सम्पीडन यदि अंसपीण्डिकावत् सम्पीडन माना जाय तो यह आधुनिक पुस्तकों में वर्णित क्रेड्डज विधि ही प्रतीत होता है क्योंकि अंसपीण्डिका को पकड़ने में हाथ की चारों अँगुलियाँ एक ओर तथा अँगुठा दूसरी ओर रहेगा। क्रेड्डज विधि में इसी प्रकार गर्भाशय को पकड़कर दबाया जाता है। नाभि के ऊपर दबाव भी गर्भाशय को संपीडित कर अपरा-पातन में सहायक होगा।

Compression of uterus after holding it just like shoulder resembles to certain extent the Crede's method because while holding the shoulder one has to keep four fingers on one side and thumb on the other and then compression is given; similarly pressure over umbilicus will also compress the uterus.

३) गर्भाशय मांसपेशी-संकोच बढ़ाकर (By increasing myometrial contractions)

योनि-धूपन, पित्तु, विभिन्न बस्त्रियाँ तथा आभ्यन्तर प्रयुक्त औषधियाँ इस वर्ग में आती हैं। शिर में अवसेचन एवं हाथ पैर आदि में आरोपित औषधियों की क्रिया-विधि के बारे में निश्चित स्पष्टीकरण कठिन है, परन्तु यह सम्भव है कि किसी प्रत्यावर्तित क्रिया द्वारा अथवा मानसिक प्रभाव के कारण हाइपोथैलमस के मार्ग से पीछेम पीयूषग्रन्थि के स्राव का निष्क्रमण होकर अपरा-पातन होता हो। उदर में आरोपित औषधियाँ सम्भवतः उदर की पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ाकर एवं उदरगुहान्तर्गत भार-वृद्धि कर अथवा प्रत्यावर्तित क्रिया द्वारा अपरा-पातन में सहायक होती हों।

Vaginal fumigations, anointments, lampoons, all *basities* and oral medicines come under this group. It is difficult to explain mode of action of the drugs used as an irrigation over the head or anointment over palm or sole, however, it is just possible that either by some reflex action or thorough psychological effect these might be influencing posterior pituitary via hypothalamus and increase the secretion of posterior pituitary which stimulates myometrium. The drugs applied over abdomen may increase intraabdominal pressure and may also reflexly stimulate the uterus.

४) हस्त-निकासन (Manual removal)

सभी विधियाँ असफल होने पर हाथ का प्रवेश कर अपरा निकालना ही अंतिम उपाय है।

When all the drugs/methods fail the placenta is removed manually.

अकाल प्रसव

(*Ākāla prasava or untimely labour*)

पूर्व पृष्ठों में सामान्य प्रसव की मर्यादा नवें मास से लेकर बारह मास तक की बताई गई है। इसके पूर्व या पश्चात् शिशु-जन्म सम्भव है कि नहीं? यदि है तो उसकी विशिष्ट व्यवस्था क्या है? आदि विषयों पर संहिताओं में सुस्पष्ट निर्देश

नहीं मिलता, फिर भी उपलब्ध संदर्भों के आधार पर विषय का स्मृष्टिकरण करने का प्रयत्न किया जा सकता है।

सामान्य प्रसव-काल से पूर्व एवं पश्चात् दोनों ही कालों में होने वाले प्रसव को अकाल प्रसव कहा जा सकता है। अकाल प्रसव को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं पूर्वकालिक या अप्रारम्भ शिशु-प्रसव तथा कालातीत प्रसव या अतिप्रारम्भ शिशु-प्रसव।

In preceding pages the description of normal labour said to occur between ninth to twelfth month has been given. Whether labour can take place before or after this period? If yes, what is its management? These both the questions are not answered in unequivocal words in the classics. However, available scattered reference related with the topic are being recapitulated.

Unimely labour can take place either before its normal duration i. e. premature labour or after its normal duration i. e. delayed labour or postmaturity.

पूर्वकालिक या अप्रारम्भ शिशु-प्रसव या विप्रसव (Premature labour)

अप्रारम्भ शिशु के जन्म से सम्बन्धित निम्नांकित वर्णन संहिताओं में मिलते हैं।

१) सभी आचार्यों ने ऋतुलाव के प्रथम तीन दिवसों में संभोग-निषेध करते हुए लिखा है कि यदि गर्भाधान हो भी गया तो या तो गर्भपातदि हो जायेंगे अथवा हीनान्न एवं अल्पायु बालक का जन्म होगा। हीनान्न एवं अल्पायु-जन्म से अप्रत्यक्षतया अप्रारम्भ शिशु का जन्म भी सम्भव सकते हैं।

२) सभी आचार्यों ने षष्ठ मास तक होने वाले गर्भलाव या गर्भपात का वर्णन दिया है एवं सप्तम मास में गर्भ सर्वाङ्ग सम्पूर्ण हो जाता है यह लिखा है, परन्तु इस गर्भ का प्रसव सम्भव है कि नहीं? यदि सम्भव है तो इसे क्या संज्ञा दी जाय? आदि का वर्णन संहिताकारों ने नहीं दिया परन्तु टीकाकार अरुणदत्त एवं मनुकोष व्याख्याकार ने स्मष्टिकरण देने का प्रयत्न किया है जो निम्नांकित है।

अ) सप्तम मास की गर्भवृद्धि के वर्णन की व्याख्या करते हुए टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है कि इस मास में गर्भ जीवन-योग्य सभी लक्षणों एवं अङ्गों से युक्त हो जाता है। अकाल प्रसव (सप्तम मास में प्रसव होने पर वह अकाल प्रसव होगा) हो जाने के कारण गर्भ में उस प्रकार के (परिपूर्ण कालोत्पन्न शिशु-सदृश) जन्म एवं जीवन के लक्षण नहीं होंगे, तथा इस मास में उत्पन्न गर्भ जीवित रहता है, किन्तु अकाल में प्रसवित होने के कारण दीर्घजीवितत्व आदि लक्षण नहीं होते। इसी न्याय के ही आधार पर अष्टम मास में ओज के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस मास में उत्पन्न शिशु जीवित नहीं रहता अथवा अकाल प्रसव होने के कारण इस मास में भी (अष्टम मास में भी) गर्भ के जीवन की सम्भावना नहीं रहती यह निश्चित ही था तो "उत्पन्न होने पर जीवित नहीं रहता" यह वाक्य अनर्थक हो जाता है, इससे भली भाँति सिद्ध होता है कि सप्तम मास में उत्पन्न शिशु जीवित रहता है।^१

आ) मनुकोष व्याख्या में लिखा है कि षष्ठम एवं षष्ठ का कथन (इन मासों में गर्भपात होने का कथन) सप्तम मास में गुणानुराज जन्म होने पर जीव-दर्शन के लिए किया है (अर्थात् बालक जीवित रह सकता है), परन्तु विगुण जन्म

१.तेन सर्वेण जन्मजीवनलक्षणानर्थेनानङ्गैश्च सम्पूर्णं भवतीत्यवशिष्टे। अकालप्रसवत्वात् न तथा गर्भस्य जन्मजीवनलक्षणो योऽसम्बन्धः सोऽप्यस्मिन् भवतीति ज्ञायते। तथा चास्मिन् मासि गर्भो जातो जीवति, किन्त्वकालप्रसवः (पा० ३१०-कालप्रभवः) त्वान तथा दीर्घजीवितत्वादिकं स्यात्। वक्ष्यति हि (स्त्री० ६६) 'काले सूतेतः परम्' इति। अमुमेव च न्यायं चेत्तसि विषयाद्ये मात्स्योऽस्वरूपनिगदप्रस्तवे 'जातो न जीवति शिशुः' इति वक्ष्यति (स्त्री० ६३)। अन्यथाऽकालप्रसवत्वादिवस्मिन् गर्भस्य जीवनं न सम्भाव्यत एव। 'जातो न जीवति' इत्येतद्वचनमर्थकमिव स्यात्। तस्मात्सप्तमे मासि जातो जीवतीति सुप्रतिपादितमेतत् ॥ (अ० ह० शा० १५८ की अरुण० टीका)

में तो सप्तमादि मासों में भी गर्भपात ही कहा जायगा। अन्य आचार्य षष्ठम एवं षष्ठ मास में ही गर्भपात मानते हैं सप्तमादि में दोष-वैगुण्य के कारण विप्रसव होता है; अर्थात् सप्तम मास में यदि गर्भ-जन्म अनुगुण है (सामान्य स्वरूप में बिना किसी विशिष्ट विकृति के हुआ है) तो उत्पन्न बालक जीवित रहता है परन्तु वह विगुण (विकार युक्त प्रसव) होने पर जीवित नहीं रहता एवं दोष-वैगुण्य के कारण प्रसव होने से इसे विप्रसव कहते हैं।^१

३) महर्षि चरक ने लिखा है कि गर्भ वृद्धि के लिए आवश्यक भावों में विपर्यय होने पर गर्भ उदर में ही मर जाता है अथवा अचिरजात होता है।^२ टीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है कि अल्प दोष होने के कारण थोड़ा विपर्यय होने पर गर्भ अचिरजात होता है।^३ अचिरजात शब्द से अचिर-काल अर्थात् सामान्य से पूर्व-काल के प्रसव का ग्रहण कर सकते हैं।

४) सभी आचार्यों ने अष्टम मास के प्रसव एवं उसके उपद्रवों का वर्णन किया है (युग् १५६ से १५८) जो स्पष्टतया अप्रारम्भ शिशु के जन्म का वर्णन है।

५) महर्षि हरीत ने लिखा है कि दोषों के बल के कारण (दोषों की विकृति के कारण) वायु से प्रेरित होकर यदि अपूर्ण दिनों में प्रसव हो जाता है तो दुर्बल बालक का प्रसव देखा जाता है।^४

६) महर्षि चरक ने गर्भ के सामान्य काल में प्रसवित होने के लिए शुक्र, असृग्, आत्मकर्म, आशय, काल तथा माता के आहार-विहार का सामान्य होना आवश्यक माना है अर्थात् इनमें विकार होने पर गर्भ का अकाल में भी प्रसव हो सकता है।^५

७) महर्षि सुश्रुत ने सिद्धान्त-रूप में वर्णन किया है कि अप्रजनाता की व्याधियों की उत्पत्ति वर्णित सामान्य व्याधियों की ही भाँति विकारित करती चाहिए। टीकाकार डह्लण ने अप्रजनाता शब्द से अकाल-प्रसूता अर्थ किया है जिससे अप्रारम्भ शिशु-जन्म का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं।^६

८) शुक्रस्य विकृत वायु के द्वारा गर्भ का शीघ्र मुञ्चन अथवा उत्सर्ग भी अप्रारम्भ शिशु प्रसव का द्योतक माना जा सकता है।^७

References pertaining to prematurity of fetus or premature labour are given here :-

i) Coitus during first three days of menstruation has been contraindicated, saying that if woman conceives during this period either she will abort or born child will have less body parts or be short lived. The birth of short-lived child or a child having less body parts etc. can be considered as an indirect reference of prematurely delivered fetus.

१. षष्ठमषष्ठयोरिति सप्तमे अनुगुणजनने जीवदर्शनयोक्तं, विगुणजनने तु सप्तमादिमासेष्वपि गर्भपातः। अन्ये तु षष्ठमषष्ठयोरैव पातः; सप्तमादिषु दोषवैगुण्याद्विप्रसव इति ॥ (पा० नि० ६४/२ की मनुकोष टीका)

२. ये ह्यस्य कुक्षौ वृद्धिहेतुसमाख्याता भवास्तेषां विपर्ययादुरे विनाशमापद्यते, अथवाऽप्यचिरजातः स्यात् ॥ (च० सं० शा० ४/२९)

३.अथवाऽप्यचिरजात इति यदा मात्रादीनां सर्वथा दोषवत्त्वेन विपर्ययो भवति, तदा विनाशमापद्यते गर्भः, यदा त्वत्पदोषवत्तया मनाविपर्ययो भवति, तदा अचिरजातो विपद्यत इति शेषम् ॥ (च० सं० शा० ४/२९ की चक्र० टीका)

४. अथ दोषवलेनापि गर्भो वापि प्रसूते। बालसम्योरिति गर्भे अपूर्णे दिवसैर्मादि ॥ २४। प्रसूतेन वाप्यथ तदर्थं बालः प्रदुर्यते ॥ (ह० सं० षष्ठ० स्या० १/२४, २५)

५. च० सं० शा० २/६ (युग् १८८ एवं ३२२)

६. अप्रजनातोरान्धं विकलितेदुत्तराद् भिषक् ॥ (अप्रजनाता अकालप्रसूता-डह्लण) (सु० सं० उ० ३८/३२)

७. च० सं० चि० २८/३४; अ० सं० नि० १५/१५, १६; अ० ह० नि० १५/१३ (युग् १७७, १७९)

ii) Upto sixth month the expulsion of fetus is called *garbhāpātā*. Exact term to be used for delivery of the fetus in seventh month (having all the body parts) has not been given in any of the classic, commentators Arunadatta and Vijayaraksita have attempted to explain this in following way :—

a) Explaining development of fetus during seventh month Arunadatta has mentioned that in this month fetus attains development of all body parts and capability to survive. Though the child born in this month does survive, however, due to *akāla-prasava* (delivery in improper time) it does not possess longevity etc. characteristics as seen in full term delivered child. If the child born prematurely in this month (*akāla-prasava*) was definitely not to survive then specific mention of death of fetus born during eighth month was superfluous. This indicates that the child born in seventh month does survive.

(b) Vijayaraksita and Śrīkanthadatta in their Madhukosa commentary have elaborated that description of *garbhāpātā* in fifth and sixth months has been specifically given to highlight the survivability of child born in seventh months. If delivery in seventh month takes place normally (normal labour) without any abnormality (diseases of the mother or fetus) or birth is *anuguna* then the born child survives, however, if delivery has occurred due to some abnormality (*virguṇa*) then the child does not survive and delivery in this month also may be called as *garbhāpātā*. Since the delivery in seventh month occurs due to abnormality of *doṣas* hence it is called “*viprasava*”.

ii) Caraka has mentioned that abnormalities of factors responsible for normal development cause intrauterine death of the fetus or it ends in *acirajāta*. This has been explained by Cakrapāṇi that if amount of vitiation of *doṣas* is less then it ends in *acirajāta*. Taking the literal meaning of word *acira* (early) *jāta* (born) it can be considered as reference for premature labour.

iv) Complications of delivery in eighth month have already been discussed earlier, which is a clear reference of premature labour.

v) Hārīta has referred that due to abnormalities of *doṣas* specially propelled by *vāyu* the delivery may take place before completing full term. Thus born child is weak.

vi) Caraka says that for normal full term delivery normalcy of *śukra*, *ārtava*, *ātmakarma*, *dāya*, *kāla* and diet along with mode of life of mother is essential. This implies that abnormality of either of these factors can cause premature labour.

vii) Suśruta has mentioned that treatment of disorders of *apaprajāta* woman should be done on the lines of any normal individual. Dahana has explained the word *apaprajāta* i.e. *akālaprasūta* or delivered in abnormal time, which can also be considered as premature labour.

viii) Aggravated *vāyu* located in *śukra* is said to cause premature expulsion of fetus.

कालातीत प्रसव या अतिप्रारम्भ शिशु का प्रसव (Delayed labour or postmaturity)

स्पष्टतर वर्णन न होते हुए भी निम्नांकित सन्दर्भ उल्लेखनीय है :—

१) महर्षि चरक ने दशम (जो अधिक युक्तिसंगत है) तथा अन्य आचार्यों ने द्वादश मास के पश्चात् गर्भ की उत्पत्ति को विकारी माना है; टीकाकार चक्रपाणि ने एकादश एवं द्वादश मास को अपेक्षकृत अल्प देय-युक्त माना है^१। महर्षि चरक ने प्रकुपित या विकृत वायु के प्रभावों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह गर्भ को (गर्भाशयान्तर) अत्यधिक काल तक धारण किए रहता है अर्थात् प्रसव विलम्ब से होता है^२। टीकाकार इन्दु ने भी एक वर्ष के पश्चात् गर्भ की अन्तस्थिति वैकलिक ही मानी है^३। टीकाकार अरुणदत्त ने इस दीर्घकालिक स्थिति का कारण वायु विकार-जन्य गर्भ-निक्रमण का अवरोध माना है एवं लिखा है कि यह विकार (प्रसव में) अवश्य करता है^४। महर्षि चरक द्वारा वर्णित शुक्रस्थ वायु के कारण गर्भ का बन्धन कालातीत स्थिति का भी द्योतक माना जा सकता है^५।

२) लीनार्थ के वर्णन में महर्षि सुश्रुत ने गर्भ का अतिकाल तक अवतिष्ठित रहना या कालातीत तक बन्ध रहना तथा टीकाकार डल्हण ने वातोपद्रव से गर्भ के निम्न-मार्ग में संकोच उत्पन्न होने से गर्भ में व्यापित या विनष्ट होने का उल्लेख किया है जो कि प्रसव-काल की सामान्य मर्यादा का उल्लंघन करके स्थित रहने वाले गर्भ का वर्णन प्रतीत होता है^६।

३) आचार्य भवमिश्र एवं योगरत्नाकर ने स्पष्ट रूप से प्रसव के समान्यकाल के व्यतीत हो जाने पर भी गर्भ के प्रसव न होने का कारण वात के द्वारा गर्भ का संकोच (प्रसव-मार्ग का संकोच) माना है तथा उसके चिकित्सार्थ उद्बुद्धल में धान्य का मूसल से कुट्टन तथा विषम यान एवं आसन के सेवन का विधान बताया है^७। इस विधि से ऐसी आशा की जा सकती है कि क्षोभन के कारण स्त्री को प्रसव-वेदनाएं प्रारम्भ हो जायें।

उत्पुक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महर्षि चरक, सुश्रुत, टीकाकार डल्हण एवं अरुणदत्त तथा आचार्य भवमिश्र एवं योगरत्नाकर ने गर्भ के अतिकाल तक बन्ध रहने के लिए कारणभूत वायु-विकार माने हैं। आधुनिक-विज्ञान में यह प्रमाणित हो चुका है कि अतिकाल-स्थायी गर्भ की गर्भाशयान्तर मृत्यु हो सकती है जिसका निर्देश टीकाकार डल्हण ने किया है, अथवा प्रसव में विकार हो सकता है जो टीकाकार अरुणदत्त द्वारा उल्लिखित है।

References pertaining to delayed labour or postmaturity are recapitulated hereunder.—

i) Intrauterine stay of fetus after tenth or twelfth month has been considered as abnormal by Caraka and others respectively. Caraka has specifically mentioned that aggravated *vāyu* can retain the fetus in uterus for a very prolong duration. Cakrapāṇi says that in that obstruction in the exit passage due to vitiated *vāyu* is the cause of prolong intrauterine stay of the fetus and this definitely causes abnormality in labour. The *vāyu* located in *śukra* can also be a cause.

१. च० सं० शा० ४/२५, सु० सं० शा० ३/३०, अ० सं० शा० २/३०, अ० ह० शा० १/१६, (पु० ४२३) तथा च० सं० शा० ४/२५ को चक्र० टीका (पु० ४२४)

२. (वायु) कुपितसु खलु विनिहन्ति गर्भान् विवृतिमापादयन्तिकालं वा धारयति । (च० सं० सू० १२/८)

३. संकल्पार्थ परश्च त्रयोदशदिषु मासेषु अन्तस्थितो गर्भो विकारित्वं भवति । (अ० सं० शा० २/३० को इन्दु टीका)

४. वातेन धारितो-रुद्धनिक्रमणो, विकारकारी भवेत् विकारमवश्यं करोति । (अ० ह० शा० १/१६ को अरुण० टी०)

५. च० सं० चि० २८/३४ (पृष्ठ १७७)

६. सु० सं० शा० १०/५७ तथा डल्हण टीका । (पु० ३०९)

७. वातेन गर्भसंकोचादसुखसमयेऽपि या । गर्भं न जनयेद्वारी तस्याः शृणु चिकित्साम् ॥
कुट्टने-मुण्डनेषा कृत्वा धान्यमुद्बुद्धले । विषमं चासनं यानं सेवेत प्रसवाधिनी ॥

(मा० प्र० चि० ७०/१०३, १०४ तथा यो० २० स्त्री रोग चि०)

2) *Linagarbha* has been described by Suśruta as the fetus having prolonged intra-uterine stay. *Dalhana* has clarified that spasm of the exit passage of fetus caused by *vāyu* produces this abnormality, in which there can be even intrauterine death of the fetus. This appears to be description of postmaturity.

3) *Bhāvaprakāśa* and *Yogarajakāra* have very clearly mentioned that due to spasm of the exit passage of the fetus caused by *vāyu*, the fetus does not deliver inspite of its full term, which is to be treated by pestling paddy in a mortar or use of jerking vehicle or uneven sitting place. These procedures might be initiating labour due to over increase in intra-abdominal pressure or irritation.

It is clear from above descriptions that postmaturity or prolonged intra-uterine stay of fetus is caused due to vitiated *vāyu*. Intra-uterine death in postmaturity and abnormality in labour has been referred by *Dalhana* and *Arundatta* respectively.

प्रसवपूर्व रक्तसाव

(*Antepartum haemorrhage*)

सप्तमस्रोतगत गर्भावस्था में अथवा प्रसव-काल में शिशु-जन्म के पूर्व रक्तसाव का स्पष्ट उल्लेख संहिताओं में नहीं है। अपर्याप्त सन्दर्भ मूढगर्भ या अन्तर्गर्भ-गर्भ के वर्णन के अन्तर्गत संहितित है; यथा-

१) महर्षि सुश्रुत ने मूढगर्भ की तथा वागमते ने अन्तर्गर्भ-गर्भ की सम्प्रति में लिखा है कि किमुण या मूढ अपान वायु अनेकों व्याधियों से कष्ट देकर तरण गर्भ को शोणित-स्नाव के द्वारा मार देती है^१। गर्भ की तरणवस्था सर्वाङ्ग सम्पूर्णता की स्थिति की होतक है अतः इस संदर्भ को सप्तम मास एवं उसके बाद के प्रसवपूर्व रक्तसाव का वर्णन मान सकते हैं।

२) टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि मक्कल (तीव्र उदर शूल) प्रजाता तथा अप्रजाता दोनों में ही होता है। अप्रजाता में गर्भ के गर्भाशय से व्युत्पन्न होकर योनिमार्ग में सक हो जाने या रुक जाने के कारण गर्भाशय से व्युत्पन्न रक्त अन्तःस्थित होकर (गर्भाशय के कारण) अर्थात् गर्भाशय में रुक कर पच्यमान हो मक्कल की संज्ञा प्राप्त करता है^२। इस रक्त की अन्तःस्थिति शब्द से प्रसव-काल में शिशु के जन्म से पूर्व होने वाले अप्रकट या गुप्त रक्तसाव का ग्रहण कर सकते हैं।

रक्तसाव में अत्यधिक शूल भी होता है।

Antepartum haemorrhage or bleeding from/or into genital tract either during pregnancy after the period of viability of the fetus or during delivery before the birth of the child has not been described in unequivocal words in *Āyurvedika* classics, however, indirect reference has been given in the description of intra-uterine death of the fetus and *mūḍhagarbha* or obstructed labour in following way—

1) In the description of pathogenesis of *mūḍhagarbha* (obstructed labour) or intra-uterine death of the fetus *Suśruta* and *Vāgbhaṭa* respectively have mentioned that vitiated and abnormally moving *apāna vāyu* producing various disorders kills or expels *larvya*

१. सु० सं० नि० ८/३ (मूढगर्भ सम्प्रति में उद्धृत)

२. अ० सं० शा० ४/२७ (अन्तर्गर्भावस्थातः वर्णित)

३. सु० सं० सू० ३३/२३ की डल्हण टीका (मूढगर्भ की आघात के लक्षणों के अन्तर्गत उद्धृत)

(young) fetus with bleeding. *Tarvya* stage of the fetus refers to the stage of development of complete body parts or seventh month onwards, thus this reference can be considered for antepartum haemorrhage.

2) *Dalhana* says that *makkalla* (severe spasmodic pain) occurs during pregnancy and puerperium both the stages. In pregnant woman during delivery the fetus after getting detached from the uterus descends and gets fixed in the *yoni* (genital passage) and obstructs the flow of blood discharged from the uterus which gets metabolised. This condition is known as *makkalla*. Bleeding before delivery of the child may be considered as description of concealed antepartum haemorrhage associated with severe pain.

मृत एवं मूढगर्भ

(*Mrtagarbha and mūḍhagarbha or intrauterine death of fetus and obstructed labour*)

गर्भाशयान्तर मृत गर्भ (*intrauterine death of fetus*)
निदान (*Etiology*)

यस्याः पुनरतिमात्रदोषोपचयाद्वा तीक्ष्णोष्णतिमात्रसेवनाद्वा वातमृदुपरीषवेगविधारणैर्वा विषमार्ग(स)नश-यनस्थानसंपीडनाभिघातैर्वा क्रोधशोकोर्ध्वाधरादिभिर्वा साहसैर्वाऽपैः कर्मभिरन्तः कुक्षेर्गर्भो म्रियते ॥

(च० सं० शा० ८/३०)

मानसगान्धुभिर्गुरुपलायैः प्रपीडितः। गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥

(सु० सं० नि० ८/१३)

यस्याः पुनरतिमात्रदोषोपचयाद्यथैतैर्वा व्यव्यादिभिरन्यैर्वा व्याधिभिः पूर्वोपचितेन वा जन्यपत्ययोः कर्मणा बन्धनान्मुच्यते गर्भः फलमिव वृत्तात् ॥ (अ० सं० शा० ४/२७)

गर्भोऽतिदोषोपचयादपथ्यैर्द्वयोऽपि वा ॥ २२ ॥

मृतेऽन्तरदर। (अ० ह० शा० २)

दोषों के अत्यधिक सञ्चित होने या तीक्ष्ण एवं उष्ण द्रव्यों के अत्यधिक सेवन अथवा वात, मूत्र एवं पुरीष के वेगों के धारण या विषम आसन में अथवा विषम रूप से बैठने, शयन करने या खड़े होने अथवा उदर में दबाव पड़ने या अभिघात लगने से या क्रोध, शोक, ईर्ष्या, भय, रास आदि से या साहस (अत्यधिक) अथवा अन्य कारणों से गर्भ कुक्षि में मर जाता है। अन्यत्र महर्षि चरक ने प्रकृतित वायु के कारण गर्भ की मृत्यु का उल्लेख किया है^१।

महर्षि सुश्रुत ने संक्षेप में लिखा है कि माता के मानसिक या आगानुक उपजाप (व्याधियों) से पीड़ित होने या (गर्भ के स्वयं की) व्याधियों से पीड़ित होने से गर्भ कुक्षि में मर जाता है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने गर्भ-मृत्यु के लिए भी गर्भस्त्रावादि के लिए वर्णित कारणों को ही उपादायी माना है, क्योंकि निदान के पश्चात् सम्प्रति लिखकर "पहिले (अर्थात् गर्भस्त्रावादि में) वर्णित किया जा चुका है"^२ उद्धृत किया है। इसके तुरन्त बाद ही अन्तर्गर्भ-गर्भ के लक्षणों का उल्लेख है जिसकी टीका में इन्दु ने लिखा है कि यदि "वृद्ध होने के बाद गर्भ की मृत्यु हो तो ये लक्षण होंगे"^३ अर्थात् कारण गर्भस्त्रावादि वाले ही रहेंगे अतः उन्हीं कारणों का यहाँ उल्लेख किया गया है।

१. (वायुः) कृपितस्तु.....विनिहति गर्भात् ॥ (च० सं० सू० १२/८)

२. श्लोभिर्हितः प्राक् । (अ० सं० शा० ४/२७)

३. यदा तु वृद्धो व्यापद्यते तदा। (अ० सं० शा० ४/२८ की इन्दु टीका)

स्त्री में दोषों के अत्यधिक उपचित हो जाने, व्यवाय आदि पूर्वोक्त कारणों से, माता या गर्भ के पूर्वजन्म के कर्मों के परिणाम-स्वरूप वृत्त से दूरे हुए फल की भाँति गर्भ बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि दोषों के अतिमान-संचय, अपथ्य सेवन एवं दैवयोग के कारण गर्भ की उदरान्तरगत मृत्यु हो जाती है। टीकाकार अरुणदत्त ने अपथ्य शब्द से "स्वभाव, मात्रा एवं कालादि से विरुद्ध भोजन" तथा दैवयोग से "शिशु के पूर्व-जन्म के अवित्त शुभाशुभ कर्म" माना है।^१

माधवनिदानकार, आचार्य भावमिश्र एवं योगरत्नाकरकार ने महर्षि सुश्रुत का अक्षरार्थः पोलन किया है।^२ अन्यत्र भावप्रकाश में बात के असंगत विकारों के अन्तर्गत गर्भनाश का उल्लेख है।^३ अर्थात् गर्भ के नाश (मृत्यु या स्वाव) का मुख्य कारण बात-प्रकोप है।

महर्षि हारीत ने निराहार रहना (माता के निराहार रहने से अथवा गर्भ की नाभिनाड़ी में अवरोध होने से गर्भ का निराहार होना) गर्भाशयान्तर गर्भ-मृत्यु का कारण माना है।^४

कारण-संहिता वर्णित नाकिनी जातहारिणी, वाग्भट द्वारा वर्णित जातवनी योनिव्यापद् तथा जननाङ्गों के जन्मजात विकारों में वर्णित प्लुतिप्रा आदि सभी व्याधियों में बारम्बार मृत-पुत्रोत्पत्ति हो एक मात्र लक्षण वर्णित है, जो सभी उपसर्ग-जन्म या जिनैतिक विकृति के कारण बारम्बार मृत सन्तानोत्पत्ति को इङ्कित करते हैं।

Due to excessive accumulation of *dosas*, excessive use of pungent and hot substances, suppression of natural urges of defecation, micturition and passing of flatus, sitting-sleeping or standing abnormally or on uneven place, compression or injury over the abdomen, anger, sorrow, jealousy, fear, horror, excessive courage and some other causes or else due to excessive aggravation of *vāyu* the fetus dies in uterus.

Suśruta says that due to physical or psychological diseases of the mother or its own disorders the fetus dies in uterus.

Vāgbhaṭa I accepting the causes of abortion as also causes of intra-uterine death of the fetus adds accumulation of *dosas*, excessive coitus, deeds of previous life of mother or fetus also in the list. Vāgbhaṭa II has included *daiva* and *Hārta* absence of diet (to the mother and fetus both) as a causative factor. Mādhavanidāna, Bhāwaprakāśa and Yogaratnakāra have followed Suśruta. *Garbhānāśa* (abortion or intra-uterine death of the fetus) is described as one of the eight disorders of *vāda* by Bhāwaprakāśa or in other words vitiated *vāda* is a causative factor.

Nākinī jāharinī and *jātaghnī yonivyāpad* described by Kāśyapa and both Vāgbhaṭas respectively and *pūtipryā* mentioned under congenital anomalies of genital organs all are characterized with repeated still births which appear to be description of repeated still births due to infection or genetic abnormality.

१. अथर्षः-स्वभावमात्रकालादिविरुद्धस्वभावैर्वा...दैवात्...अन्यज्जातिशुभाशुभकर्मवशात्.....॥
(अ० ह० शा० २४/२२ का अर० टीका)

२. मानसा.....प्रतीकृतः ॥ (सु० सं० सद्गुण ही)
(मा० नि० ६४/९ प्रतीकृतः के स्थान में निपीडितः; पा० प्र० चि० ७०/१८ एवं यो० १० स्त्री १० चि०)

३. पा० प्र० चि० २४/१५

४. निराहाराच्च भ्रियते यदि गर्भोऽन्तरे स्थितः ॥ (ह० सं० तृ० स्थान ५२/१६)

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सभी आचार्यों द्वारा वर्णित निदानों को यदि एक साथ रखा जाय तो गर्भाशयान्तर गर्भ-मृत्यु के निम्न कारण होते हैं।

- १) दोषों का उपचय या शारीरिक उपताप-गर्भिणी का शारीरिक दोषवैषम्य या व्याधियाँ।
- २) आहार वैषम्य-गर्भिणी के पोषण-जन्म विकार।
- ३) विहार-वैषम्य एवं अभिघात-आघातदि के कारण अपरा की आंशिक विवृति हो प्रसव-पूर्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रक्तस्राव एवं गर्भ-मृत्यु।

४) मानसिक उपताप-मानसिक विकार।

५) दैवयोग या पूर्वजन्म-कर्म-अज्ञात कारण।

६) गर्भ की व्याधियाँ-व्याधि या विकृति-पीडित गर्भ।

७) विषम आसन, शयन एवं स्थान-यद्यपि गर्भिणी के विषम रूप से या विषम स्थान में सोने, बैठने या खड़े होने का गर्भ के ऊपर हातिकाक प्रभाव सुनिश्चित रूप से प्रमाणित नहीं है, फिर भी यह सम्भव है कि गर्भिणी स्त्री की विशिष्ट शारीरिक-स्थिति के कारण यदि गर्भाशय में अत्यधिक दबाव पड़े तो वह अपरा के रक्तस्राव को प्रभावित कर गर्भाशयान्तर गर्भ की मृत्यु का कारण हो जाय। आधुनिक काल में भी कुछ दशकों पूर्व गर्भ के अनुप्रस्थ आसन को सामान्य आसन या उदय में परिवर्तित करने के लिए गर्भिणी द्वारा विशिष्ट शारीरिक आसनों का प्रयोग वर्णित है, अतः यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि स्त्री के विभिन्न शारीरिक आसन गर्भ के अनुप्रस्थ आसन को सामान्य आसन या उदय में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसी प्रकार गर्भिणी के द्वारा शारीरिक विषम स्थितियों का सतत प्रयोग गर्भ के आसन या उदय के विकार भी उत्पन्न कर सकता है। असामान्य रूप से प्रसावित होने वाला गर्भ प्रसव के समय मर भी सकता है।

८) निराहार रहना-माता के निराहार रहने से स्त्री को पोषण-जन्म विकार हो वे गर्भाशयान्तर गर्भ-मृत्यु का कारण हो सकते हैं। गर्भ का निराहार रहना दो स्थितियों में सम्भव है (१) अपरा विकृत हो जाय, फल-स्वरूप गर्भ को पोषण एवं शुद्ध वायु पहुँचाने में असमर्थ हो जाय (जो गर्भाशयान्तर गर्भ-मृत्यु के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है) (२) गर्भ की नाभि-नाड़ी में सत्य ग्रन्थियाँ पड़ जाँय; इस स्थिति में गर्भ को पोषण एवं शुद्ध वायु न मिलने से गर्भ की लात्कातिक मृत्यु हो जाती है।

आधुनिक विज्ञान में भी गर्भाशयान्तर-गर्भ की मृत्यु के कारणों को तीन भागों में विभाजित करते हैं मातृगत, गर्भगत एवं अज्ञात जिसका स्पष्ट उल्लेख आयुर्वेदिक संहिताओं में मिलता है। गर्भाशयान्तर गर्भ-मृत्यु तथा गर्भस्राव का एक साथ हो वर्णन होने के कारण पूर्ववर्णित गर्भस्राव या पात के अन्तर्गत उल्लिखित निदानों को भी इस व्याधि के कारण-स्वरूप मानना चाहिए।

Considering all above causes together following factors may be held responsible for intra-uterine death of the fetus:

- 1) Accumulation of *dosas* or physical disorders—Various maternal physical disorders.
- 2) Abnormalities of diet—Nutritional factors.
- 3) Abnormalities of mode of life and trauma—Trauma causing partial placental detachment resulting into revealed or concealed antepartum haemorrhage and fetal death.

4. Psychological disorders.

१. "भैरुर्भूत आर्वु मिद्विचकिरि" पृष्ठ ४३६

5. *Daiva or deeds of previous life*—Idiopathic

6. *Disorders of fetus*—Congenital or acquired abnormalities or disorders of fetus.

7. *Abnormal postures*—Though effect of pregnant woman's posture over the fetus is not established, however, it is just possible that due to abnormal posture if the uterus is not compressed for a longer duration, the placental circulation may get influenced and cause fetal anoxia or death. Few decades back postural treatment was advised to correct transverse lie specially shoulder presentation.¹ Hypothetically it can be presumed that if postural treatment can correct the abnormal position of the fetus, continuous use of a particular abnormal posture can very well produce abnormality of presentation or position of the fetus. Due to delivery in abnormal position the fetus can die during labour.

8. *Absence of diet*—Dietetic deficiency to the mother may produce nutritional disorders thus fetal death. Diet to the fetus may be influenced either due to placental insufficiency resulting in inadequate supply of nutrients including oxygen to the fetus (one of the most important cause of intra-uterine fetal death) or due to true knots of umbilical cord causing complete absence of nutrients as well as oxygen resulting in immediate fetal death.

All above mentioned factors can be summarized into three categories i. e. maternal, fetal and idiopathic. The causes detailed under abortion should be considered here also.

सम्प्राप्ति (Pathogenesis)

बन्धनान्बन्धने गर्भः फलमिव वृत्तात् स मुक्तबन्धनो गर्भशय्याभितक्तस्य यकृत्सीहीनत्वविवेकसंज्ञमानः कोष्ठमङ्गशोभमापादयति । ततः कोष्ठमङ्गशोभमाद्राद्युत्पन्नो मूढः कुक्षिवस्तिषाश्रौदयोनिशूलानाहविण्मूत्रसङ्गानापाद्य गर्भं व्यावयति तरुणं शोणितभावेन । सोऽभिहितः प्राक् । (अ० सं० शा० ४/२७)

निदान की हो भाँति गर्भसंज्ञा के लिए वर्णित सम्प्राप्ति की हो गर्भशय्याभितक्तस्य गर्भ-मृत्यु की सम्प्राप्ति मानकर वर्णन किया जा रहा है ।

पूर्ववर्णित कारणों से गर्भ अपने बन्धनों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार कि फल अपने वृत्त से । वह बन्धनों से मुक्त हुआ गर्भ गर्भशय्या का अतिक्रमण करके यकृत, प्लीहा और आन्त्र के विकारों (अन्तर्गतों) से अवसंसमान हो कोष्ठ में संक्षोभ उत्पन्न करता है । कोष्ठ के संक्षोभ के कारण अपान वायु मूढ (विण्णु) होकर कुक्षि, वस्ति, पाश्वर्य, उदर एवं योनि में शूल, आनाह, मल, मूत्रारोघ आदि व्याधियों को उत्पन्न करके तरुण गर्भ को शोणित के साथ व्यवहन करती है अर्थात् गोचे की ओर फेकती है । जो पहिले कहा जा चुका है (अर्थात् गर्भसंज्ञा का वर्णन पहिले आ चुका है) (विमर्श मूढगर्भ की सम्प्राप्ति के ही साथ वर्णित है) ।

Pathogenesis of intra-uterine death of fetus and abortion has been described together which is being recapitulated here.

Due to preciously mentioned causes fetus gets detached from its bonds just like a fruit. The fetus getting detached from the bonds, transgressing the uterus, descending from the hollow spaces of liver, spleen and bowels irritates the *kosha* (abdominal cavity). The *apāna vāyu* getting obstructed or moving abnormally due to this irritation produces pain in

1. Manual of midwifery by Jelliet and Madill; page 436.

pelvic and bladder region and also in flanks, abdomen and vagina, distension of abdomen, retention of urine and feces and expels the young fetus with bleeding.

लक्षण (Clinical features)

तस्याः स्तिमितं सन्ध्यामुद्रामातं श्रीमशमार्गतीमिव भवत्यस्यन्तो गर्भः, शूलमधिकमुपजायते, न चायः प्रादुर्भवन्ति, योनिर्न प्रवर्तते, अक्षिणी चास्याः स्रस्ते भवतः, ताम्पति, व्यथते, भ्रमते श्रसिति, अतिबहुला च भवति, न चास्या वेपथुर्भावे यथावदुपलभ्यते, इत्येवं लक्षणं स्त्रियं मृतगर्भेयामिति विद्यात् ॥ (च० सं० शा० ८/३०)

गर्भास्पन्दनामवीनां प्रणयः श्यावपाण्डुता । भवत्युच्छ्वासपूतित्वं शूलं चान्तरुते शिरो ॥

(सु० सं० नि० ८/१२)

विवृद्धे तु गर्भे सन्ध्यां स्तिमितं श्रीमशमार्गतीमिवोदरमाभाति । शूलमधिकमुपजायते न च स्पन्दते गर्भो नायः प्रादुर्भवन्ति न स्ववति योनिरक्षिणी चास्याः स्रस्ते तथा भूशमरतिपरीता व्यथतेऽप्यथा चेष्टते ताम्पति भ्राम्यति रोदित्यहर्निशं न स्वपिति पूर्युच्छ्वासात्कुच्छ्वासित्यतिकष्टं प्राणिनि जक्षितीत्येवंचिदां स्त्रियं मृतगर्भा विद्यात् ॥

(अ० सं० शा० ४/२८)

मृतेऽन्तरुदरं शीतं सन्ध्यां भ्रमं भूशमश्रुत् ॥ गर्भास्पन्दो भ्रमस्तृष्णा कुच्छ्वासोऽप्युच्छ्वासं क्लमः ॥ २३ ॥

अरतिः स्रस्तेनेत्यसामवीनामस्पन्दवः ॥ २४ ॥ (अ० ह० शा० २/२३, २४)

उस (मृतगर्भ) स्त्री का उदर स्तिमित (गति रहित या गीले वस्त्र से अच्छादित सा), सन्ध्या (जकड़ा हुआ सा); आतल (तना हुआ), शीतल, अस्पान्तातं सदृश (उदर के अन्दर पथर रखे हुए की प्रतीति सदृश) हो जाता है । गर्भ में स्पन्दन नहीं होता । अत्यधिक वेदना उत्पन्न हो जाती है । आवाँ (प्रसव वेदनाओं) प्राप्ति नहीं होती । योनि से स्राव नहीं होता, आँखें स्रस्त या शिथिल हो जाती हैं, उसे अंधकार की प्रतीति, व्याधा, भ्रम, श्वास तथा अत्यधिक कष्ट होता है, यथावत् वेगों (मल-मूत्रादि के) की उपलब्धि नहीं होती । इन लक्षणों को देखकर यह स्त्री मृतगर्भा है यह जानना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि शिशु के अन्तर्भूत हो जाने पर गर्भ के स्पन्दनों तथा आवाँ का नाश, श्यावता या पाण्डुता (त्वचा के वर्ण का परिवर्तन), उच्छ्वास में पुति-गन्धि तथा शूल आदि लक्षण होते हैं ।

टीकाकार डल्हण ने अन्तर मृतगर्भ के लक्षणों का कुछ आचार्यों द्वारा किया गया वर्णन उद्धृत किया है यद्यपि स्वयं पुनस्तुति दोष के कारण इसे उचित नहीं माना । मृतगर्भ के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है :- वह अन्तर्भूत गर्भ शोफ-युक्त होकर बस्ति के सदृश फैल जाता है (जिस प्रकार पूर्ण बस्ति उदर में स्वस्थान से ऊपर की ओर फैल जाती है उसी प्रकार शोफ-युक्त गर्भ उदर को आपूरित कर लेता है), उस (गर्भ) से आवृत होने के कारण स्त्री के उदर में अत्यधिक आनाह हो जाता है, वह अपने अङ्गों को उछालती सी है, उसके मूत्रबस्ति, क्लोम, प्लीहा, यकृत, पुष्पुस तथा हृदय में भेदनवत् पीड़ा होती है । गर्भ के द्वारा पीड़ित हो वह (वायु) ऊपर की ओर जाती है तथा वह (स्त्री) शोथ-युक्त, मोहित (संज्ञा-विहीन) हो जाती है, श्वासकष्ट हो जाता है । पुति-गन्धि, अत्यधिक स्वेदन, बिह्ला एवं तालु की शुष्कता हो जाती है, उसे कम्पन होता है, चक्र आते हैं तथा उसका जीवन अवरुद्ध सा हो जाता है (प्राणवरोध या श्वासवरोध सा हो जाता है) । इन लक्षणों को देखकर चिकित्सक को मृतगर्भ जानना चाहिए ।

१. यदा सोऽन्तरुतो गर्भः शूलो वस्तिरिवलतः । तेनावृताया नार्यास्तु कुक्षिनाहते घृणम् ॥

उत्क्षिपन्त इवाङ्गानि मूत्रवस्तिश्च भिद्यते । क्लोम प्लीहा यकृच्चैव पुष्पुसं हृदयं तथा ॥

गर्भेण पीडितं ह्येदृशं प्रकामति स्त्रियाः ।

सा शूलते मुहति च कुच्छ्वासा च जायते । पूतिगन्धस्तथा स्वेदे बिह्ला तालु च शुष्यति ॥

वेपते भ्राम्यति तथा जीवितं चोपश्रयते । एतैरङ्गैर्विज्ञानीयात् मृतं गर्भं चिकित्सकः ॥

इति पठन्ति, तत् न पठन्ते पुनस्तुतवत्, जेज्जटाचायादिभिः परिहृतत्वाच्च । (सु० सं० नि० ८/१४ को डल्ह० टीका)

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि गर्भ के विवृद्ध होकर अन्तर्गुत होने पर गर्भिणी^१ का उदर स्तब्ध, सिमिप, शीत एवं अमगमर्मा की तरह प्रतीत होता है। शूल अधिक उत्पन्न होता है। गर्भ का स्पन्दन, आवी का प्रादुर्भाव एवं योनि से स्राव नहीं होता, आँखों का संसर्जन होता है, अत्यधिक वेधनी अनुभव करती है, व्याधा होती है, अन्त्या (असामान्य) चेष्टा करती है, अँधेरा प्रतीत होता है, चक्रर आता है, रात-दिन रोती रहती है, सोती नहीं, क्षय में पूर्णगन्धि एवं अति कष्ट होता है, बहुत ही कठिनार्द्र से प्राण-धारण करती, एवं कुछ भी खाती है, इन लक्षणों वाली स्त्री को मृतागर्भा समझना चाहिए।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि गर्भ को मृत्यु हो जाने पर उदर शीत, स्तब्ध तथा ध्मात (फूला हुआ) हो जाता है, अत्यधिक कष्ट होता है, गर्भ का स्पन्दन नहीं होता, भ्रम, तृष्णा, ख्यासकष्ट, क्लम, अर्शित या खड़े होने-बैठने-सोने आदि में चित्त की अस्थिरता, सस्त-नेत्रता तथा आवी या प्रसवकालोत्पन्न वेदनाओं^२ की अनुत्पत्ति आदि लक्षण होते हैं।

आचार्य भवमिश्र एवं योगरत्नाकरकार ने महर्षि सुश्रुत का अक्षरशः अनुसरण किया है। परन्तु माधवकार ने अन्य लक्षण महर्षि सुश्रुत सदृश ही देते हुए शूल के स्थान में सूनाता अर्थात् शोफ वर्णित किया है।^३

महर्षि हारीत ने विभिन्न प्रकार के मृदागर्भों के लक्षणों के उत्तरान् मृतागर्भा के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि भ्रम, मूर्च्छा, तृष्णा, आध्मान, वायु का अवरोध, विह्वलता या बेधनी, मूर्च्छा (तन्द्रा), वमि, परधता या कठोरता (उदर या गर्भाशय की कठोरता) एवं दीनता की उत्पत्ति हो जाय तो उस स्त्री को मृतागर्भा जानना चाहिए; एवं उसकी शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। अब मैं उस महामोह (मृदागर्भा स्त्री) की चिकित्सा कहूँगा।^४

The abdomen of woman (having dead fetus) becomes still, stiff, stretched, cold and stony hard. Fetal movements disappear. She feels severe pain. Labour pains do not start. There is absence of vaginal discharges, eyes become lax. She feels darkness, uneasiness, giddiness, dyspnoea and intense restlessness. She does not get natural urges (pass urine or feces) properly.

Suśruta has mentioned that besides cessation of fetal movements and labour pains, there occurs blackish or whitish discoloration of skin, foul smell in expiration and pain. Dalhana has added that the dead fetus getting edematous fills the abdomen just like a full bladder. Due to this, the lady gets abdominal distension, throws her body parts upwards and feels splitting like pain in the region of urinary bladder, pancreas (*kloma*), spleen, liver, lungs and heart. *Vāyu* getting compressed by fetus moves upwards. She becomes edematous,

१. यदा तु बृहो व्यापद्यते तदा गर्भिण्याः ॥ (अ० सं० शा० ४/२८ की इन्द्र टीका)

२. अतिः-स्थानासनसंशयान्दिवावस्थितत्वं चेतसः..... अवीर्णं आसनप्रसवकालञ्च शूलविशेषाणां ॥ (अ० ह० शा० २/२४ की अरुण० टीका)

३. अ) गर्भास्पन्दन..... शिशोः। (सु० सदृश ही) (भा० प्र० वि० ७०/१९, यो० १० स्त्रीरोग० वि०)

आ) गर्भास्पन्दन..... शूलताऽन्तर्गुते शिशौ। (सु० सं० सदृश ही) (भा० वि० ६४/८)

४. भ्रममूर्च्छातृष्णाभ्रमं वातरोधञ्च विह्वलम्। मूर्च्छावर्षिं सपारब्धं दीनतन्मृतागर्भाच्छि ॥ १॥
मृतागर्भं विजानीयादशुक्रातो रित्यामपि। अतो वक्ष्यामि भैषज्यं महामोहं विशारदः ॥ १०॥
(श्लोक में मूर्च्छा शब्द दो बार आया है, एक स्थान पर तन्द्रा वर्णन अधिक शुक्तिर्सात है।)
(ह० सं० तृतीय ५/२९ व १०)

unconscious and suffers from dyspnoea, foul smell, excessive perspiration, dryness of tongue and palate, convulsions and giddiness. Her life is imperilled.

Vāgbhata II has followed Caraka while Mādhavanidāna, Bhāvanīśtra and Yogarānā-kara the Suśruta, however, Mādhavanidāna has substituted word pain with edema.

Hārta has mentioned giddiness, unconsciousness, thirst, flatulence, retention of flatus, uneasiness, drowsiness, vomiting, hardness of abdomen and miserable state as clinical features.

चिकित्सा (Treatment)

तस्य गर्भशल्यस्य जग्राद्युपपन्नं कर्मसंशमनमित्याहुः के, मन्त्रादिकमथवेदविहितमित्येके, पर्णदृशकर्मणा शल्यहर्त्रा हरणमित्येके ॥ (च० सं० शा० ८/३९)

उस गर्भशल्य के लिए एक आचार्य का मत है कि जग्राद्यु-पतनार्थ वर्णित कर्म एवं संशमन-चिकित्सा करें, एक आचार्य का मत है कि अथर्ववेद-वर्णित मन्त्रादि कर्म करें तथा अन्य आचार्य का कहना है कि कर्म को देखे हुए अथर्व अनुभवी शल्यहर्त्रा द्वारा शल्य का आहरण कराये। टीकाकार चक्रपाणि ने 'एके' शब्द की व्याख्या में लिखा है कि उपर्युक्त तीनों प्रकार के ही कर्मों से मृतागर्भाहरण सम्यक्-रूप से साधित होने में सन्देह है अतः इस प्रकार मममत्तान्तर दिए गए हैं। अन्य महर्षि चक्र ने आहरण योग्य शल्यों में गर्भशल्य का ही उदाहरण दिया है।^१

This *garbhasālyā* (dead fetus acting as extraneous substance lodged in the body and giving it very great pain) should be treated either with suppressive measures along with the methods prescribed for the treatment of retained placenta or with the use of hymns mentioned in *atharvaveda* or should be extracted by an experienced surgeon. Cakrapāṇi has clarified that since proper extraction of the fetus with either of the methods is difficult, hence these different opinions have been given. At another place Caraka has cited *garbhasālyā* as an example of *sālyas* to be treated by extraction.

शल्योद्धरण के पश्चात् चिकित्सा (Treatment after extraction of fetus)

व्यापगतगर्भशल्यां तु स्त्रियमामगर्भा सुतासीव्यष्टिभूमिदिरासवानामन्तममये सामर्थ्यतः पायवेदगर्भकोष्ठशुद्ध-धर्मतिविस्मरणार्थं प्रहर्षणार्थं च, अतः परं संशीर्णनै(बृहणैः-पातभेद)र्जलानुशिक्षिभिरस्नेहसंप्रयुक्तैर्वावादिभिर्वा तत्कालयोगिभिराहारैरुपचरेद्दोषधातुक्तेदविशोषणमात्रं कालम्। अतः परं स्नेहणवैस्तिभिराहारविधिभिश्च दीपनीय-जीवनीयबृहणीयमधुरवातहरसमाख्यातैरुपचरेत् ॥

परिपक्वगर्भशल्याः पुनर्विमुक्तगर्भशल्यायास्तदहरेव स्नेहोपचारः स्यात् ॥ (च० सं० शा० ८/३९)

आमगर्भा स्त्री का शल्य निकल जाने के बाद गर्भकोष्ठ की विशुद्धि, अर्ति-विस्मरण तथा प्रहर्षण के लिए सुरा, सीधु, अरिष्ट, मधु, (विशिष्ट प्रकार की मदिरा), मदिरा तथा आसव आदि अन्य मद्य-भेदों को स्त्री को सामर्थ्य के अनुसार पीने को दें। तत्पश्चात् बल की रक्षा करने वाले, बृंहण या संतर्पण परन्तु स्नेह रहित यवाग एवं उस समय के लिए उपयुक्त आहार के द्वारा तब तक उपचार करें जब तक कि दोष एवं धातु के क्लेश का विशेषण न हो जाय। तत्पश्चात् दीपनीय,

१. 'एके' इति वचनेन अग्रतिथेन च जग्राद्युपपन्नकर्मदीनं त्रयाणामपि मृतागर्भाहरणं प्रति सम्यक्साधनता नस्तीति दर्शयति । ... ॥ (च० सं० शा० ८/३९ का चक्र० टीका)

२. गर्भशल्यमाहार्यमाणम्..... ॥ (च० सं० सू० २५/४०)

जीवनीय, वृंक्षणीय (गण की औषधियाँ) तथा मधुर एवं वातहर द्रव्यों से साधित स्नेह का पान, बलित तथा आहार-विधि के द्वारा उपचार करें।

परिपक्व गर्भशल्य वाली स्त्री के गर्भशल्य से विमुक्त होने के दिन से ही स्नेह का प्रयोग प्रारम्भ कर दें।

नोट—यद्यपि महर्षि चरक ने यह चिकित्सा स्वरूप से आमर्ष के शल्य के निकल जाने के बाद की वर्णित की है परन्तु चूँकि इसके पूर्व ही अन्तर्मुत गर्भ के शल्योद्धारण का वर्णन है अतः यह उसकी भी चिकित्सा समझी जा सकती है। महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भटादि ने अन्तर्मुत गर्भ एवं मूढगर्भ की एक ही चिकित्सा वर्णित की है जो बाद में लिखी जायगी। चूँकि महर्षि चरक ने “मूढगर्भ” शब्द का प्रयोग नहीं किया अतः इनके द्वारा वर्णित विषय को पृथक् लिखा गया है जैसे यह चिकित्सा मूढगर्भ के लिये भी की जा सकती है।

After extraction of *śalya* or expulsion of *ama* (immature) fetus, for cleansing the uterus and alleviation of pain along with elevation of her mood the woman should be prescribed *surā, sṛdhu, arisṭa, madhu* (a type of wine), *madirā* and *āsava* or other alcoholic drinks according to her strength. After this to protect her strength she should be given fat free, anabolic or satiating rice gruel and appropriate diet beneficial for this period. This dietetic regimen should be continued till the *kleda* (moisture) of *doṣas* and *dhatūs* is cleared. After this uncting substances, enemias and specific diet medicated with appetizing, life prolonging, anabolic, sweet and *vāta* suppressing drugs should be prescribed.

The woman with mature fetus should be prescribed fats from the day of extraction of the fetus.

मूढगर्भ (Mūdhagarbha or obstructed labour)

परिभाषा (Definition)

“.....तदेव कदाचिद् विवृद्धसम्यगागतमपत्यपथमनुप्राप्तमनिरस्यमानं विगुणापानमोहितं गर्भं मूढगर्भमित्याचक्षते ॥ (सु० सं० नि० ८/३)

तं तु गर्भं कदाचिदसम्यगागतपत्यपथमेकधा प्रतिपन्नं विगुणेन वायुना पीडितं मोहितं च मूढगर्भमित्याहुः ॥

(अ० सं० शा० ४/२९)

वही गर्भ जब कभी विवृद्ध होकर असम्यक् प्रकार से आया हुआ, अपत्यपथ को प्राप्त होकर भी अनिरस्यमान या निकल सकने में असमर्थ एवं अपान वायु की विगुणता के कारण संमोहित हो जाता है तो मूढगर्भ कहा जाता है। टीकाकार डल्लण ने असम्यगागत से विलोमभाषा से आया हुआ तथा संमोहित से मूर्च्छित गर्भ अर्थ किया है।

महर्षि वाग्भट ने भी लिखा है कि वही गर्भ जब कभी असम्यक् अपत्यपथ में अनेक रूप से प्रतिपन्न होकर विगुण-वायु के द्वारा पीडित एवं मोहित हो जाता है तो मूढगर्भ कहा जाता है।

माधवनिदान, योगरत्नाकर तथा भावप्रकाशकार ने लिखा है कि मूढ (गति-रहित) वायु गर्भ को मूढ कर देती है।

The same fetus (which has not aborted) after getting developed, coming abnormally, unable to come out even after reaching its passage (pelvis and vagina) and stupified or swooned due to abnormality of *apāna vāyu* is termed as *mūdhagarbha*.

१.असम्यगागतं विलोमभगोनागतम् ।संमोहितं मूर्च्छितम् । (सु० सं० नि० ८/३ को डल्ल० टीका)

२. मूढः कतिपि पवनः खलु मूढ गर्भ ॥ (पा० नि० ६४/३, भा० प्र० ७०/१९३ एवं यो० १० स्त्रीतो० चि०)

Vāyubhāta says that the same fetus, reaching abnormal passage, coming with different presentations, troubled by abnormal *vāyu* and unconscious or swooned is known as *mūdhagarbha*.

Mādhavanīdāna, Yogaratnākara and Bhāvaprakāśa have mentioned that stupified *vāyu* going astray stupifies the fetus.

विमर्श (Comments)

मूढगर्भ की उपरिलिखित परिभाषा को व्याख्या करने के लिए तीन बातों पर विचार आवश्यक है।

- अ) किस स्थिति के गर्भ को मूढता की संज्ञा दी जाय अर्थात् परिभाषा का विस्तरेषण।
- आ) गर्भ में मूढता उसकी किस अवस्था या आयु में आती है।
- इ) मूढता जीवित गर्भ में होती है या मृत में।

अ) मूढगर्भ की शास्त्रोक्त परिभाषा का विस्तरेषण

‘मूढ’ शब्द ‘मुद्’ धातु से बना है जिसके अनेकों अर्थों में संज्ञाविहीन, मूर्च्छित, विषयगामी एवं दिशाविहीन होना भी है। मूढ का शाब्दिक अर्थ ‘आलसी’ भी होता है। आचार्य भावमिश्र ने मूढ का अर्थ रुद्ध-गति किया है^१ जब कि मधुकोष-व्याख्याकार ने व्यासक-गति या अवरुद्ध एवं असामान्य गति माना है। मूढगर्भ के विवरण को देखते हुए विषयगामी या मूर्च्छित, आलसी या गति-रहित गर्भ को मूढगर्भ की संज्ञा देना उचित होगा। आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट वर्णित मूढगर्भ की परिभाषा आधुनिक विज्ञान-वर्णित अवरुद्ध-प्रसव की अधिकांश स्थितियों का समावेश कर लेती है, विशेषकर यदि स्थीकरण की सुगमता के लिए ‘कदाचिद्’ को प्रत्येक शब्द के पूर्व लगा लिया जाय यथा “कदाचिद् विवृद्धम्”, “कदाचिद् असम्यक् आगतम्” आदि। संहिताओं में वर्णित विषय को निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं।

१) विवृद्ध गर्भ—‘वि’ उपसर्ग का अर्थ विशिष्टता के लिए ग्रहण करके ‘विवृद्ध’ से विशिष्ट प्रकार से वृद्ध अर्थात् सामान्य से भी अधिक स्थानिक या सार्वदैहिक वृद्ध अर्थ किया जाय तो इसके अन्तर्गत गर्भ के अतिवृद्धि-जन्य (यथा अतिभाण का या सार्वदैहिक अतिवृद्धि, स्थानिक अतिवृद्धि यथा जलोदर, जलशीर्ष, अर्बुद आदि से) प्रसव-अवरोध को समाभूत कर सकते हैं।

२) असम्यक् आगत या अनेकधा प्रतिपन्न—असम्यक् अर्थात् असामान्य रूप से प्रसव के लिए अवतरित हुआ गर्भ। अनेक प्रकार से अवतरित गर्भ-वर्णन के अन्तर्गत सभी विकृत आसनों एवं उदरों का समावेश हो जाता है।

३) अपत्यपथ में अनुप्राप्त हो अनिरस्यमान या असम्यक् अपत्यपथ में प्राप्त गर्भ—महर्षि वाग्भट ने अपत्यपथ की विकृति का असम्यक् शब्द से उल्लेख किया है। महर्षि सुश्रुत ने यद्यपि अपत्यपथ की विकृति का निश्चित उल्लेख नहीं किया परन्तु अपत्यपथ में (सामान्य रूप से) आकर न निकल पाने के लिए पथ का विकृत होना अवश्यभावी है, अर्थात् इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रसव में बाधक अपत्यपथ के सभी विकारों का समावेश हो जाता है।

४) अपान वायु के वैगुण्य से संमोहित गर्भ—सामान्यतया संमोहित गर्भ से सभी व्याख्याकारों ने मूर्च्छित गर्भ अर्थ किया है, परन्तु यहाँ यह तथ्य अवलोकनीय है कि विगुणा मातृ-शरीर-स्थित अपान वायु की है जिसका गर्भ की संज्ञा से कोई संबंध नहीं है। गर्भ का संज्ञा-नाशन या मोहन करना गर्भ-शरीर स्थित प्राण वायु का कार्य है जिसकी विगुणता का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। अपान वायु का कार्य गर्भाशय को उत्तेजित एवं संकुचित करके गर्भ को बाहर निकालना है अतः इसकी विगुणता होने पर गर्भाशय-पेशी-संकोच सामान्य न होने से गर्भ की गति का सम्मोहन हो सकता है जिससे

१. मूढः = रुद्धगतिः । मूढगर्भं रुद्धगतिं गर्भं । (पा० प्र० चि० ७०/१९३ को टीका)

२. मूढो व्यासकगतिः ॥ (पा० नि० ६४/३ को मधु० व्याख्या)

प्रसवोन्मुख गर्भ गति के अवरोध होने से आगे नहीं बढ़ पाएगा अर्थात् यह विकार गर्भाशय-क्रिया-विकार-जन्य प्रसव-अवरोध का द्योतक है।

आ) मूढ़गर्भ के द्योय गर्भ की आयु

आचार्यों ने कहाँ पर भी मूढ़गर्भ के द्योय गर्भ की आयु का निर्धारित उल्लेख नहीं किया। गर्भसाव के वर्णन के उपरान्त 'विवृद्ध' शब्द से गर्भ की आयु का सम्बोधन है। गर्भ का साव तीसरे या चौथे मास तक हो जाता है अतः चौथे मास के पश्चात् के काल को गर्भ में मूढ़गर्भ मान सकते हैं। टीकाकार डल्हण ने चतुर्थ मास के पश्चात् गर्भ के शरीर में स्थिरता आ जाने के कारण पात स्वरूप होने या घनत्वयव हो जाने से मूढ़गर्भता होने का निर्देश किया है^१। परन्तु इन्होंने स्वयं ही अध्याय के प्रारम्भ में 'सर्वायव सम्पूर्ण', मन एवं बुद्धि आदि से युक्त, विगुण अपान-वायु से सम्पन्न गर्भ को मूढ़गर्भ माना है^२। सर्वायव सम्पूर्णता गर्भ में गर्भाशयस्थ के सप्तम मास में आती है अर्थात् मूढ़गर्भ सप्तम मास के पूर्व नहीं हो सकती। शाल्योद्धरण के पश्चात् की चिकित्सा का वर्णन करते समय प्रसवकालोत्तर मूढ़गर्भ एवं अकाल मूढ़गर्भ की कुछ पृथक् पृथक् व्यवस्था वर्णित की है^३; जिससे स्पष्ट होता है कि सम्भवतः टीकाकार डल्हण स्वयं गर्भ की आयु के बारे में सन्देहास्पद थे।

मधुकोष व्याख्याकार ने उचित प्रसव-काल में ही गर्भ में मूढ़गर्भ मानी है^४। आयुर्वेद में उचित प्रसव-काल नवम मास की प्राप्ति के पश्चात् ही माना गया है।

प्रत्यक्ष क्रियात्मक अनुभव के आधार पर सप्तम मास के पूर्व गर्भ में मूढ़गर्भ की उपस्थिति समुचित प्रतीत नहीं होती अतः 'विवृद्ध' से 'विशिष्ट रूपेण वृद्ध' अर्थ करने से एवं डल्हण-लिखित 'सर्वायव सम्पूर्णता' तथा मधुकोष की 'उचित प्रसव-काल' आदि व्याख्या के साथ सामञ्जस्य स्थापित करने पर गर्भ में मूढ़गर्भ का आना सप्तम मासोपरान्त मानना ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। यह तथा अष्टाङ्गसंग्रहोक्त गर्भाशयान्तर गर्भ-मृत्यु तथा सुश्रुतेक मूढ़गर्भ की सम्प्राप्ति को देखने से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आचार्यों ने उस गर्भ का यकृत, प्लीहा और आंव के विचार से अवशंसमान होना वर्णित किया है। गर्भ-युक्त गर्भाशय यकृत एवं प्लीहा की सीमा तक अष्टम मास में ही पहुँच पाता है अर्थात् इस आयु के बाद ही गर्भ में मूढ़गर्भ होने की सम्भावना मानी जा सकती है।

इ) मूढ़गर्भ जीवित होता है या मृत

यद्यपि महर्षि चरक ने "मूढ़गर्भ" शब्द का प्रयोग नहीं किया, परन्तु शल्यहर्त्रा आदि द्वारा आह्वय करवाने का निर्देश मूढ़गर्भ के वर्णन की ओर ही द्दिष्ट करता है। यद्यपि बिना गति की विगुणता के भी यदि मृतगर्भ प्रसवित न हो तो शल्यहर्त्रा द्वारा आह्वय करवाना पड़ सकता है फिर भी अन्य आचार्यों द्वारा वर्णित विषय से सामञ्जस्य रखते हुए इसे मूढ़गर्भ मान सकते हैं; अर्थात् महर्षि चरक ने स्पष्ट-रूप से मृत गर्भ में ही गति अवरोध या विगुणता की सम्भावना को व्यक्त किया है।

आचार्य वाग्भट ने मृत गर्भ के लक्षणों के वर्णन के पश्चात् ही लिखा है कि 'तं तु' अर्थात् वही मृत गर्भ मूढ़गर्भ

१. तत्र द्रवस्य स्रवणे मूढ़गर्भनाम नास्ति, विगुणानिलमोहानिमलक्षणाभवात् ॥ गर्भं विवृतिः गर्भमृतिः प्रत्यवेत् साररूपा भवेत् ॥ एतेन मासचतुष्टयं यावत् मूढ़गर्भता नास्तीत्युक्तम् ॥ तत इत्यादि ॥ ततश्चतुर्मासादूर्ध्वं स्थिरशरीरस्य विवृतिः पातः पातरूपा भवेत् ॥ एतेन विवृतिरियं न साररूपा, तस्माच्चतुर्धमासनन्तरं घनत्वयवत्वाद्मूढ़गर्भो भवतिरुक्तम् ॥ (सु० सं० चि० ८/१ एवं १० डल्ह० टीका)
२. सर्वायवसम्पूर्णो मनोबुद्ध्यादिसंयुतः। विगुणापानसंयुतो मूढ़गर्भोऽभिधीयते ॥ (सु० सं० चि० ८/१-२ की डल्ह० टीका)
३. सु० सं० चि० १५/१०-१८ की डल्हण व्याख्या।
४. उचित प्रसवकाले यथा मूढ़ो गर्भः स्यादाह ॥ (मा० चि० ६४/३ की मधु० व्याख्या)

को प्राप्त होता है; परन्तु इन्होंने ही मूढ़गर्भ को व्याख्या में मोहित होने का भी वर्णन किया है, 'मोहित' का टीकाकार इन्द्र ने 'मूर्च्छित'^१ अर्थ किया है। यदि गर्भ मृत था तो उसके मूर्च्छित होने का प्रश्न ही नहीं उठता! पुनःश्च चिकित्सा का वर्णन करते समय सचेतन या जीवित गर्भ के अङ्गों के काटने का निषेध तथा उसे प्रसवित करने के उपायों का वर्णन किया है^२ जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि वाग्भट जीवित गर्भ में भी मूढ़गर्भ होना मानते थे।

महर्षि सुश्रुत एवं उनके अनुयायी अन्य आचार्यों (माधवनिदान, भावप्रकाशादि) ने परिभाषा, निदान या सम्प्राप्ति में कहाँ पर भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि गर्भ जीवित होता है या मृत, परन्तु चिकित्सा में गर्भ के जीवित होने अर्थात् जीवित मूढ़गर्भ के प्रसव-विघ्न का स्पष्ट निर्देश किया है^३। चिकित्सा स्थान वर्णित 'मृते च' के 'च' शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि यदि प्रसव करने में मन्त्र-तन्त्र चिकित्सा असफल हो जाय तो जीवित गर्भ को भी हाथ से खींचकर बाहर निकालना चाहिए^४। इन सभी आचार्यों ने भी जीवित गर्भ के छेदन का निषेध लिखा है^५।

अर्थात् जीवित या मृत कोई भी गर्भ मूढ़गर्भ को प्राप्त हो सकता है।

उपयुक्त वर्णन को दृष्टिगोचर रखते हुए मूढ़गर्भ की निम्न परिभाषा कर सकते हैं।

"सर्वायव सम्पूर्ण, जीवित या मृत, असम्पक् प्रकार से आया हुआ अधवा/और असम्पक् अपत्य पथ को प्राप्त होकर तथा अपान वायु के विगुणत्व-जन्य गर्भाशय-पेशी के असामान्य संकोचों के कारण अनिरस्यमान गर्भ मूढ़गर्भ या अवरुद्धप्रसव होता है"।

In explaining above definition three points have to be considered—

- a) Which specific condition should be considered as state of stupefaction (*mūḍhagatva*) or clarification of above definition.
- b) At what gestational age the fetus can become a *mūḍhagatva* (obstructed labour).
- c) Whether this obstruction occurs in alive or dead fetus.

a) Explanation of definition given in classics
The literal meaning of word *mūḍha* which is derived from *dhatu* "mūḥ" is to become stupefied, unconscious or swooned, to become bewildered or going in wrong direction and become lazy. Obstructed movement and abnormal alongwith obstructed movement is the explanation given for the word *mūḍha* by Bhāvamiśra and Madhukosa commentary respectively. Thus *mūḍhagatva* refers to the condition in which the fetus has gone astray, is swooned with absence of descend. The definition given by Suśruta and Vāgbhaṭa actually includes almost all the conditions of obstructed labour described today, as explained hereunder—

१. मोहितं मूर्च्छितम् ॥ (अ० सं० शा० ४/२१ की इन्द्र टीका)
२. अ० सं० शा० ४/३३, अ० ह० शा० २/३७ (सचेतन गर्भछेदनान्तर्गत वर्णित)
३. जीवति तु गर्भं ॥ (सु० सं० चि० १५/५)
गर्भः जीवति मृते तु ॥ (मा० प्र० चि० ७०/१२१)
४. मृते चेति । चकारादफलीमृतेषु मानन्तत्रप्रसूतिजननव्यापेषु जीवत्यपीत्यनुक्तं समुच्चिनोति ।
(सु० सं० चि० १५/१ की डल्ह० टीका)
५. सु० सं० चि० १५/१०, भा० प्र० चि० ७०/१२३, यो० १० स्त्री० १० चि० (सचेतन गर्भछेदनान्तर्गत वर्णित)

i) **Viridha garbha**—Prefix 'vi' denotes 'special' or 'exaggerated' and word *viridha* the growth, thus it includes obstruction caused by generalized over size of the fetus i.e. macrosomia or local over-growth of a part of the fetus such as ascies, hydrocephalus or congenital tumours etc.

ii) **Asanyak āgata or anekadhā pratipanna** (presenting abnormally or with various presentations)—The fetus coming abnormally or with different presentations includes all malpre-sentations and positions.

iii) **Unable to deliver after reaching the passage**—Vāgbhata has clearly mentioned the word abnormal passage. Suśruta though not mentioning the word abnormal has written that fetus after reaching (normally) to the passage gets obstructed, which is possible only when the passage is abnormal or this heading includes all the conditions of abnormal passage causing obstructed labour.

iv) **Abnormality of apāna vāyu causing samnohana of garbha**—The word "samnohana" has been explained by all the commentators as unconsciousness of the fetus, however, the word also refers to stupefaction. One has to consider that here abnormality is of *apāna vāyu* situated in the maternal body, which is totally unrelated to the consciousness of the fetus. The maintenance of consciousness of the fetus is a function of *prāna vāyu* situated in fetal body which is not deranged, thus the question of fetus becoming unconscious does not arise, rather it gets stupefied. Main function of *apāna vāyu* is to expel the fetus by stimulating myometrium, naturally its abnormality will produce obstruction to the movement or delivery of the fetus by influencing myometrial activity. Considering these points this description should be considered as obstruction to the process of descend of fetus or in the progress of labour due to abnormal or feeble uterine contractions or uterine inertia.

b) The gestational age of fetus in which it can get obstructed

None of the classics have mentioned specific gestational age of fetus for this condition. Suśruta after describing *garbhasṭāva* (abortion upto fourth month) has mentioned that *mūḍhagarbha* can occur in *viridha* (developed or grown-up) fetus. Explaining this verse Dalhana says that in fifth and sixth month since the fetal parts become solidified, hence obstruction to the delivery can occur at this stage, however, in the beginning of the chapter he himself has mentioned that the fetus having all his body parts and association of *mana* and *buddhi*, getting stupefied due to vitiated *apāna vāyu* is known as *mūḍhagarbha*. The development of all body parts is complete in seventh month or in other words obstruction in the delivery can not occur before seventh month. Further he has prescribed postoperative management for *prasavakālopanna mūḍhagarbhā* (obstruction during normal delivery period) and *akāla mūḍhagarbhā* (obstruction during delivery in improper time) separately. This shows that Dalhana was confused about the gestational age of the fetus.

In Madhukosa commentary *mūḍhātā* (obstruction) is accepted only during normal delivery period i. e. ninth month onwards.

In practice obstruction to the labour of a fetus before seventh month is generally not

seen. Considering above mentioned three points i. e. *viridha* or over developed, attainment of all body parts and delivery in appropriate time, the *mūḍhagarbhātā* (obstruction to the labour) should be considered only after seventh month.

This hypothesis is strengthened when one considers the pathogenesis of intrauterine death of fetus described by Vāgbhata and of *mūḍhagarbha* given by Suśruta, where-in they have mentioned that the fetus descends from the space in-between liver and spleen. To this height uterus reaches only during eighth month or in other words obstruction to the labour occurs eighth month onwards.

c) Whether this obstruction occurs in alive or dead fetus

Caraka while advising that if intrauterine dead fetus does not deliver with medicines or *mantras*, the woman should be referred to surgeon, has not used the term *mūḍhagarbha*, however, since the descriptions is identical to that of *mūḍhagarbha*, hence it may be concluded that according to Caraka the abnormality or obstruction in labour occurs only in dead fetus.

Vāgbhata after describing the intrauterine dead fetus says further that the same fetus if gets stupefied then is called *mūḍhagarbha*. However, in the definition he himself has mentioned unconsciousness or swooning of the fetus. In the treatment also he has contra-indicated destructive surgery of alive fetus, thus it is clear that he accepted that the obstruction can occur in dead or alive fetus.

Though Suśruta and Mādhava etc. in defining etiopathogenesis have not mentioned specifically that whether fetus in dead or alive, however, in the treatment clear distinction between management of alive or dead *mūḍhagarbha* has been made.

Thus it can be inferred that dead or alive any fetus can get obstructed or become *mūḍhagarbha*.

Considering all above points *mūḍhagarbha* can be defined in following way—
"Alive or dead fetus, after attaining development of all its body parts or after seventh month of pregnancy, presenting abnormally and/or in abnormal passage, associated with abnormal uterine action due to vitiation of *apāna vāyu* is *mūḍhagarbha*".

मूढगर्भ-निदान (Etiology of mūḍhagarbha)

जैसा पूर्व वर्णित है अधिकांश सीद्धान्तकारों ने गर्भस्त्राव के निदान एवं सम्प्रप्ति का वर्णन कर उसी निदानों को गर्भश्लेष्मान्तर गर्भ-मृत्यु के लिए भी उलटादोही माना है। महर्षि वाग्भट ने उसी मृत गर्भ में ही अपत्यपथ विकार एवं उदर विकार आदि के कारण मूढता होना वर्णित किया है अतः गर्भस्त्राव एवं अन्तर्मृत गर्भ के कारणों को ही मूढगर्भ के कारण मानना चाहिए। सभी आचार्यों ने गर्भ की मूढता का मुख्य कारण अपान वायु की विगुणता ही माना है। महर्षि सुश्रुत ने अथवाय का नाम ही मूढगर्भनिदान रखकर आगे गर्भस्त्रावन्तर्गत वर्णित निदानों का उल्लेख किया है अतः वे निदान यहाँ पुनः उद्धृत किए जा रहे हैं।

१. च० सं० शा० ८/३०; सु० सं० शि० ८/३; एवं १३; अ० सं० शा० ४/२७ व २६; अ० ह० शा० २/२२, मा० शि० ६४/३, ९; मा० प्र० शि० ७०/११३, ११८ वं यो० २० स्त्री० रो० चि० (पृष्ठ ४७९, ४७२, ४७८)

गाम्भ्यमर्थानवाहनाध्यगामनप्रसूतलनप्रपतनप्रपीडनधावनाभिधातविषमशयनसनेपवासवेगाभिधाताति-
रुक्षकदुर्गतिकभोजनशोकातिक्षारसेवेनातिसारवमनविरचनेप्रेङ्खलनाजीर्णभर्षशातप्रभृतिभविष्येर्बन्धनान्मुच्यते गर्भः,
फलमिव वृन्तबन्धनादभिधातविशेषैः ॥ (सु० सं० नि० ८/३)

मैथुन, यान, वाहन, अध्यगमन, प्रसूतलन, प्रपतन, प्रपीडन, धावन, अभिधात, विषम शयनसने (विषम स्थान में या विषम रूप से सोना या बैठना), उपवास, वेगाभिधात, अतिरुक्ष, कटु, एवं तिक भोजन, शोक, क्षार का अतिसेवन, अतिसार, वमन, विरेचन, प्रेङ्खलन, अजीर्ण एवं गर्भशातक औषधियों के प्रयोग से वृन्त से च्युत फल की ही भाँति गर्भ अपने बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।

महर्षि हारीत ने मूढगर्भ के विशिष्ट निदानों का वर्णन करते हुए लिखा है कि विरुद्ध आहार के सेवन (माता के द्वारा), गर्भ की व्यथा अथवा अल्पाधिक शिरःशूल (माता को) होने से गर्भ पीड़ा (कष्ट) को प्राप्त करता है अथवा वह गर्भ तिर्यक होकर भाद्वार को छोड़ता है (योनिमार्ग से बाहर आने का प्रयत्न करता है) या अन्य किसी कारण से जब गर्भ मर जाता है तो (स्त्री) कष्ट को प्राप्त करती है अथवा लज्जा के कारण (अथवा दूँ भी) भग के संकोच से संकुचित भग (योनिद्वार या मूलाधार) में (गर्भ प्राप्त होने से) मूढगर्भ हो जाता है अब उसके लक्षण कहते हैं^१ ।

Most of the authors have described etiology of abortion and intrauterine death of fetus together. The description of intrauterine dead fetus by Caraka hints that it can also get obstructed. Vāgbhata has clearly mentioned that the same dead fetus presenting abnormally in abnormal passage is called *mūḍhagarbha*. Thus the etiology of abortions and intrauterine death of fetus should be considered as causative factor for *mūḍhagarbha* also. Suśruta giving caption to the chapter as "*mūḍhagarbhanidāna*" (etiology of obstructed labour) has discussed the causes of abortion which are being recapitulated here.

Due to excessive coitus, riding on carriages or animals, travelling, staggering, falling down, compression, running, trauma, sleeping or sitting abnormally or on uneven place, fasting, suppression of natural urges, use of excessive dry, hot or pungent edibles, grief, excessive use of *kṣāra* (alkalies), diarrhoea, vomiting, purgation, swinging, indigestion and use of abortifacient drugs, the fetus gets detached from its bonds in the same way as a fruit gets detached from its stalk due to trauma.

Hārīta opines that use of incompatible diet by the mother, diseases of the fetus and severe headache to the mother cause troubles to the fetus. Due to these troubles or its expulsion in oblique position or due to other reasons the fetus dies and woman gets trouble. Sometimes due to shyness or otherwise the *bhaga* (vaginal passage or introitus or perineum) gets constricted (spasm), the fetus approaching this constricted passage becomes *mūḍha-garbha*.

विमर्श (Comments)

गर्भस्त्राव, अर्न्तमृत गर्भः, परिभाषा एवं निदानान्तर्गत वर्णित सम्पूर्ण विषय तथा अर्न्तमृत गर्भ के लक्षण एवं मूढगर्भ

१. विरुद्धाहारसेवाभिधरा गम्यव्याधयः च । अतिमूर्धनपीडयाः पीडां प्राप्नोति चार्धकः ॥
तिर्यक्वाणि च गर्भश्च त्यक्त्वा ह्यर्ध भगस्य च । अन्येना भिद्यतेऽपत्यं तेन कष्टं प्रपद्यते ॥ २॥

अथवा लज्जा स्त्रीणां सङ्कोचान् सङ्कुचिते भगे । मूढगर्भश्च जानीयात्स्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥
(हा० सं० तुल्यस्थान ५२/१ से ३)

की आसन्नता के लक्षणों को एक साथ अवलोकन करने पर मूढगर्भ या अवरुद्ध प्रसव के निम्न कारण सामने आते हैं ।

- १) गर्भाशय-पेशी के कार्य में विकृति
- २) गर्भ की विकृति
- ३) अपत्यपथ का वैगुण्य

प्रत्येक स्थिति का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

१) गर्भाशय-पेशी के कार्य में विकृति

गर्भाशयिक पेशियों की प्रसव के लिए आवश्यक संकुचन शक्ति में विकृति होने से प्रसव में अवरोध हो जाता है । पेशियों के कार्य में निम्न कारणों से विकार हो सकते हैं ।

अ) शारीरिक व्याधियाँ-सभी आचार्यों ने आहार-वैषम्य का वर्णन किया है इस आहार-विरुद्ध-वैषम्य से स्त्री के सामान्य स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ कर दौर्बल्यादि होने से प्रसव के समय गर्भाशय की संकुचनशीलता में प्रभाव पड़ सकता है । आहार-वैषम्य गर्भजन्य विषमयता का भी एक कारण है जिसका सर्वप्रथम लक्षण शिरःशूल होता है जो महर्षि हारीत द्वारा स्पष्टतः वर्णित है । गर्भजन्य विषमयता में प्रसव अधिकांशतः अवरुद्ध हो जाता है ।

आ) मानसिक स्थिति का प्रभाव-ह प्रमाणित तथ्य है कि स्त्री की मानसिक स्थिति (क्रोध, शोक, भय आदि) का गर्भाशय-संकुचन में प्रभाव पड़ता है । महर्षि हारीत-वर्णित लज्जा से भग का संकोच इसी आशय का द्योतक है ।

इ) नाड़ी-कार्य में विकार-सभी आचार्यों ने अपान वायु के वैगुण्य का वर्णन दिया है जिसकी विकृति के कारण गर्भ की गति अवरुद्ध हो जाती है । अपान वायु को ही प्रथम प्रसूति मारुत शब्द से सम्बोधित किया गया है । इस वायु या नाड़ीवह संस्थान के कार्य में विकृति होने से गर्भाशय-पेशी का सामान्य संकुचन न होकर प्रसव अवरुद्ध हो सकता है । नाड़ी के कार्य में विकृति होने से गर्भाशय पेशी में दो प्रकार के विकार होते हैं यथा गर्भाशयसंकोचनाल्यता एवं अत्यधिक या असामान्य संकोच । अपान वायु वैगुण्य से गर्भ का सम्मोहन (पृ० ४७९), गर्भ के अवाक् न होने पर (पृ० ४८५ से ४८६) एवं गर्भसङ्ग के लिए वर्णित (पृ० ४८२ से ४८४) चिकित्सा तथा गर्भ का मनुकुष्ठ या मथ्यगति होना आदि गर्भाशय की संकोचाल्यता के द्योतक हैं । अरभ की भाँति उदरगुभृति, आवी की अनुपस्थिति में अत्यधिक शूल (पृ० ४७५, ४७६) एवं मक्कल्ल गर्भाशय के अत्यधिक या असामान्य संकोच की स्थिति के वर्णन प्रतीत होते हैं । कभी-कभी गर्भाशय में विकार होने से गर्भाशय-ग्रीवा का सामान्य विस्फार नहीं हो पाता जिसका वर्णन योनिंसंवृति या योनिंसंवरण शब्दों से किया गया है । अपान वायु के वैगुण्य से गर्भ का सम्मोहन सम्भवतः गर्भाशय की प्राथमिक क्रियाविहीनता एवं अन्य द्वितीयक क्रियाविहीनता या अन्य प्रकार की कार्य-विकृति के द्योतक प्रतीत होते हैं ।

ई) दैवयोग-अज्ञात कारण से गर्भाशय-पेशी संकोच-विहीनता ।

२) गर्भ-विकृति

गर्भ-विकृति पुनः दो प्रकार की हो सकती है आकृति की विकृति एवं आसन या उदर की विकृति ।

अ) आकृति की विकृति-महर्षि हारीत ने स्पष्टतया गर्भ की व्याध को कारणभूत माना है । विभिन्न गर्भाङ्ग विकृतियाँ कभी कभी गर्भ की मूढ़ता का कारण बन जाती हैं जैसे एनसिस्केल आदि । विवृद्ध गर्भ पूर्व (पृ० ४७९) वर्णित है ।

आ) उदर या आसन की विकृति-असम्यक् आगत, अनेकधा प्रतिपन्न एवं तिर्यक् आगत आदि वर्णन तथा लक्षणान्तर्गत वर्णित विभिन्न गतियाँ इस विकृति की स्पष्ट द्योतक हैं । गर्भिणी द्वारा विषम आसन-शयन आदि से गर्भ के उदर या आसन में होने वाला प्रभाव पूर्ववर्णित है (पृष्ठ ४७३) ।

३) अपत्यपथ का वैगुण्य

अपत्यपथ में निम्न विकार हो सकते हैं।

अ) गर्भाशय-विकार—गर्भकोष की अपक्वता या विकृति होने से मूढगर्भ के असाध्य होने का स्पष्ट उल्लेख हारीत ने (मूढगर्भ की असाध्यता में वर्णित) किया है।

आ) श्रोणिगुह्य-विकार—असम्यक् अपत्यपथ में अनुप्राप्त या अपत्य-पथ में अनुप्राप्त परन्तु अनिरस्यमान आदि वर्णन (पृ० ४७९) स्त्री की श्रोणि की अस्थियों के विकार को इंगित करता है।

इ) गर्भाशय-ग्रीवा-विकार—योनिसेवृत्ति या योनिसेवरण (असाध्य मूढगर्भ में वर्णित) गर्भाशय-ग्रीवा के संकोच या विस्फार न होने का वर्णन है।

ई) मूलाधारपीठ (पेरिनीअम) काठिन्य—हारीत-वर्णित लज्जा से भग-संकोच (पृ० ४८४) इस स्थिति का द्योतक है।

उ) योनिभ्रंश—योनि अर्थात् गर्भाशय-ग्रीवा का भ्रंश होने से प्रसव के समय उसका सामान्य विस्फार नहीं हो पाता एवं प्रसव में अवरोध होता (असाध्य मूढगर्भ में वर्णित)।

For understanding the etiology of *mūḍhagarbha*, the etiology of abortion and intra-uterine death of fetus, definition of *mūḍhagarbha*, its etiology and features of bad prognosis have to be considered together. On this basis following causative factors may be held responsible for *mūḍhagarbha* (obstructed labour)—

- 1) Abnormality in functions of uterine musculature i. e. abnormality or failure of power.
- 2) Abnormalities of fetus or passenger.
- 3) Abnormalities in the passage—
Details of each point are given hereunder—

1) Abnormalities in the function of uterine musculature

Following factors may cause uterine inertia or irregular uterine contraction.

a) **Nutritional disorders**—Improper diet may deteriorate general health of the woman, thus influence the contractility of myometrium, besides unbalanced diet is also one of the causative factor for toxæmia of pregnancy, of which headache a very common symptom is very clearly mentioned by Hārīta. In toxæmia of pregnancy labour often gets obstructed.

b) **Effect of psychology**—Psychology of an individual influences functions of reproductive system, spasm or constriction of vagina due to shyness mentioned by Hārīta is description in this direction. This shyness or fear can influence myometrial contractions.

c) **Abnormality of functions of nervous system**—These functional abnormalities are of two types i.e. absence of contraction or uterine inertia and irregular or excessive uterine contraction. The cessation in the process of descend of fetus due to abnormality of *apāna vāyu* and the treatment prescribed for failure of descend of fetus as well as *garbhasaṅga* hint towards uterine inertia. The former probably refers to primary uterine inertia while the latter

to the secondary uterine inertia. Presence of *śūla* (pain) in the absence of *avīras* (labour pains), feeling of stony hardness of abdomen (uterus) and *makkalīa* (tetanic spasm of uterus) etc. seem to be descriptions of irregular/abnormal or excessive myometrial contractions. Sometimes due to ineffectual uterine contractions there is failure of dilatation of cervix which has been described as *yonisampryiti* or *yonisamvarana*.

d) **Daiyavoga**—Uterine inertia due to idiopathic cause.

2) Abnormalities of passenger

The passenger had two types of abnormalities i.e. of size or shape and presentation with position.

a) **Abnormality of size or shape**—Hārīta has mentioned diseases of fetus as a cause which may be considered as abnormality of shape. Abnormality of size has already been discussed earlier under *vīradha garbha*.

b) **Abnormal presentation or position**—Abnormally presented, presenting with other parts, coming obliquely etc. descriptions and various modes of presentations are clear description of abnormal presentations/positions. Influence of maternal postures over fetal presentation/position has already been discussed earlier.

3) Abnormalities of passage

In the maternal passage following abnormalities are seen.

a) **Abnormalities of uterus**—Hārīta has stated that in the presence of abnormalities of *garbhakoṣa* (uterus) the *mūḍhagarbha* becomes incurable.

b) **Abnormalities of pelvis**—‘Reaching abnormal maternal passage’ and ‘unable to come out’ is a clear description of abnormalities of maternal pelvis.

c) **Abnormalities of cervix**—*Yonisampryiti* or *yonisamvarana* refer to failure in dilatation of cervix.

d) **Rigidity of perineum**—Spasm of *bhaga* due to shyness probably denotes rigidity of perineum due to psychogenic factors.

e) **Prolapse of cervix**—*Yonibhramā* has been enlisted under the clinical features of bad prognosis of *mūḍhagarbha*. In cases of cervical prolapse, proper dilatation of cervix does not take place thus obstructs the labour.

मूढगर्भ की सम्प्राप्ति (*Samprapṛiti* or *pathogenesis* of *mūḍhagarbha*)

निदान की ही भाँति महर्षि वाग्भट द्वारा वर्णित अन्तर्गर्भ की ही सम्प्राप्ति को मूढगर्भ की भी सम्प्राप्ति समझना चाहिए, महर्षि सुश्रुत-वर्णित सम्प्राप्ति ही यहाँ दी जा रही है। महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने लगभग एक तरह की ही सम्प्राप्ति लिखी है।

स विमुक्तबन्धनो गर्भाशयमतिक्रम्य यकृत्स्नीहान्निवैरैरवसंसमानः कोष्ठसङ्क्षोभमापादयति। तस्या जठरसङ्क्षोभाद्वायुरापानो मूढः पार्श्ववस्तिशीर्षोदयोनिशूलानाहमूत्रसङ्गानामन्तर्ममापाद्य गर्भं व्याचरति (व्यापादयति-पाठभेद) तरुणं शोणितस्तत्रवेण। (सु० सं० नि० ८/३)

in turn excites the *apāna* *vāyu*. This vitiated and abnormally moving *apāna* *vāyu* initiates expulsion of young fetus associated with bleeding per vaginam and pain in flanks etc. symptoms. This fetus getting obstructed in its passage and having absence of further progress in known as *mūdhagarbha*.

मूढगर्भ के लक्षण (Clinical features of *mūdhagarbha*)

१) सामान्य (General)

महर्षि सुश्रुत एवं अष्टासंग्रहकार ने मूढगर्भ के सङ्ग तथा गतियों का वर्णन दिया है एवं सम्प्रति के अन्तर्गत पाश्चादि में शूल तथा मूत्रसङ्क्रादि का वर्णन है जो कि मूढगर्भ के लक्षण माने जा सकते हैं। माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर ने संक्षेप में लिखा है कि मूढ (विषम गति) वायु (अपान) गर्भ को मूढ कर योनि एवं उदरदि में शूल तथा मूत्रसङ्ग उत्पन्न कर देती है^१।

Pain etc. symptoms have already been described under pathogenesis. *Mādhavanidāna* etc. books have mentioned that abnormally moving *apāna* *vāyu* obstructs the progress of fetus and produces pain in abdomen, vagina and retention of urine.

२) मूढगर्भ के विशिष्ट लक्षण या गतिवै (Specific clinical features or mode of presentations of *mūdhagarbha*)

मूढ गर्भ के विशिष्ट लक्षण उसकी अनेक प्रकार से प्रसूति होने की गतिवै ही है। चिकित्सा-सौकर्य की दृष्टि से आचार्यों ने तीन प्रकार का सङ्ग (गर्भ का माला की श्रोणिगुहा में अवधारण) वर्णन किया है। (१) शिर से^२ या शिर के वैष्णव^३ से (२) अंस या अंस के वैष्णव से^३ (३) जघन^४ या जघन के वैष्णव^३ से। जो क्रमशः असामान्य या विकृत शीर्ष, अनुप्रस्थ तथा स्मिक् आसन के द्योतक हैं।

विभिन्न गतियों (या उदरों) का वर्णन करते समय आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि चौँक मूढगर्भ वायु-विकार-जन्म व्याधि है अतः विविध वायु के द्वारा पीडन एवं उसकी विविध गतियों के कारण मूढगर्भ की अनेकों गतिवै होती है^५।

महर्षि सुश्रुत एवं उनके अनुयायी माधवकार आदि ने आसन एवं उदर के आधार पर मूढगर्भ के चार भेद तथा आठ गतियों का उल्लेख किया है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने संक्षेप में ऊर्ध्व, तिर्यक् एवं न्युज तीन गतियों का वर्णन कर सुश्रुत आठ गतियों को आठ स्थान शब्द से सम्बोधित कर उनका चिकित्सात्मक उल्लेख किया है। महर्षि हारीत ने दोषप्राधान्य के आधार पर मूढगर्भ के लक्षणों का उल्लेख किया है। विषय के सम्पर्क ज्ञान की दृष्टि से मूढगर्भ के भेदों एवं गतियों का पृथक् पृथक् वर्णन किया जा रहा है।

१. मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भः। शूलं च योनि जटारादिषु मूत्रसङ्क्रमः॥
(मा० नि० ६४/३; भा० प्र० वि० ७०/१२३ एवं यो० १० स्त्री० वि०)

२. त्रिविधस्तु सङ्गो भवति। शिरस्यसे जघने वा। (अ० सं० शा० ४/३४)

३. स्वभावज्ञा अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति, शिरसि वैष्णव्यादस्योर्ध्वमन्य वा।
(शिरसि वैष्णव्यात् वक्रत्वात्। अंसयोर्ध्वमन्य च वैष्णव्यमनुवर्तते, वैष्णव्यं वक्रता-उदरत्न) (सु० सं० वि० १५/४)

४. अ) गर्भस्य गतयश्चिन्ना जायतेऽनिलकोपतः॥ (सु० सं० वि० १५/४४)
आ) विष्णुनिर्गतप्रतिगोडनवैचित्र्यारसङ्ख्याति च। (अ० सं० शा० ४/२९)

इ) गर्भस्य हि गतिं चिन्ना करोति विष्णुोऽनिलः॥ (अ० ह० शा० २/३६)

ई) पुनोऽनिलेन विष्णुनेन ततः स गर्भः, संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम्॥
(मा० नि० ६४/४, भा० प्र० वि० ७०/१२३ एवं यो० १० स्त्री० वि०)

Specific clinical features of *mūdhagarbha* are its various positions and presentations. The fetus engages in the pelvic cavity by its head or shoulder or thighs (brech). These indicate abnormalities of vertex, transverse and breech positions/presentations.

Mūdhagarbha occurs due to abnormality of *vāyu*, being compressed by this abnormal *vāyu*, having various movements it presents in numerous ways, however, for understanding the subject *Suśruta* and *Mādhavanidāna* etc. have described these in two way : (i) types of *mūdhagarbha* (ii) its *gates*. *Vāgbhaṭa* has described only different *gates* in relation to treatment. *Hārta* has envisaged the role of different *dosas* and classified *mūdhagarbha* accordingly.

अ) मूढगर्भ के भेद (Classification of *mūdhagarbha*)

ततः कीलः प्रतिच्युते बीजकः परिष इति॥ (सु० सं० नि० ८/४)

मूढ गर्भ चार प्रकार का होता है^१।

वह मूढगर्भ कील, प्रतिच्युत, बीजक एवं परिष (चार प्रकार का) होता है।
माधवनिदान, भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर पुस्तकों में भी सुश्रुत के चार भेदों का ही उल्लेख है^२। महर्षि हारीत ने दोष प्राधान्य के आधार पर वातज, पित्तज, रतेषज, इन्द्रज एवं सज्जिपातिक मूढगर्भ के लक्षणों का वर्णन कर मूढगर्भ के सात भेदों का उल्लेख किया है^३।

Suśruta, *Mādhavanidāna*, *Bhāvaprakāśa* and *Yogaratanākara* have classified *mūdhagarbha* under *kīla*, *pratichyuta*, *bījaka* and *pariṣa* etc. four categories. *Hārta* has described *vātaja*, *pittaja*, *kaphaja*, *dwandwaja* (due to two *dosas* together) and *sānjipātika* etc. seven types.

आ) सुश्रुतादि वर्णित मूढगर्भ के लक्षण (Clinical features of *mūdhagarbhas* described by *Suśruta* etc.)

१) कील या संकीलक (*Kīla* or *saṅkīlaka*)

तत्र उर्ध्वबाहुशिरःपादो यो योनिमुखं निरूपणद्ध कील इव सः कीलः॥ (सु० सं० नि० ८/४)

जो बाहु, शिर एवं पैर ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील की भाँति अवरुद्ध करता है वह कील है (वि० ८ स)।
माधवनिदान, भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर पुस्तकों में भी संकीलक के यही लक्षण हैं। मधुकोष व्याख्या में उद्धृत भोज द्वारा वर्णित लक्षण भी उपर्युक्त वर्णन से सामंजस्य रखते हैं^४।

१. अ) इति चतुर्विधो.....१ (सु० सं० नि० ८/४)

आ)द्वयं चतुर्विधं। (मा० नि० ६४/५)

२. संकीलकः प्रतिच्युतः परिषोऽथ बीजः। (मा० नि० ६४/६, भा० प्र० वि० ७०/१२४ एवं यो० १० स्त्री० से० वि०)

३. ह्यो सं० तुतीयस्थान ५/२४ से ८ (लक्षणान्तर्गत वर्णित)

४. अ) तेषुर्ध्वबाहुचतुर्विधः शिरसा च योनिम्। सङ्गो च यो भवति कीलकवत् स कीलो॥

(मा० नि० ६४/६, भा० प्र० वि० ७०/१२४, यो० १० स्त्री० वि० योनिम् के स्थान में योनी पाठ)

आ) तेनोर्ध्वबाहुचतुर्विधोऽपिः कीलकवत्तनो योऽन्यां संकीलकः।भोजोऽप्येता गतयः पठ्यन्ते। तथाहि-
ऊर्ध्वबाहुशिरःपादो रूपाद्योनिमुखं तु यः। प्रतिकीलोपमस्थित्या स च कीलक संज्ञितः॥

(मा० नि० ६४/६ की मधुकोष व्याख्या)
इ) उच्छिद्यैर्बाहुचतुर्विधोऽपिः, योनी यः सङ्गो भवति स कीलः=कीलकाख्यो मूढगर्भः। (मा० प्र० वि० ७०/१२४ की व्याख्या)

The fetus obstructs just like a wedge having both hands, feet and head upwards. (fig 8c)

२) प्रतिबुद्ध (Pratikūḥa)

निःसृतहस्तपादशिराः कायमङ्गी प्रतिबुद्धः । (सु० नि० ८/४)

हाथ पैर एवं शिर से निकल हुआ परन्तु काय या शरीर से सङ्गी अर्थात् रक्ता हुआ गर्भ प्रतिबुद्ध मूढगर्भ है (चि० १२) ।

माधवनिदान आदि अन्य लेखकों ने केवल हाथ तथा पैर दिखाई देने का ही वर्णन किया है परन्तु मधुकोष व्याख्याकार ने सुश्रुत सदृश ही शिर का भी साथ ही निर्माण माना है तथा स्पष्ट कर दिया है कि कील में सभी ऊपर होकर पुष्टभाग से अवरोध होता है प्रातःखुर उसका ठीक विपरीत है जिसमें हस्त, पाद एवं शिर सभी बाहर निकलते हैं अर्थात् उदर से अवरोध होता है । भोज ने लिखा है कि योनिमुख से जो गर्भ नीचे से, पार्श्व से अथवा संकुचित होकर निकलता है वह प्रतिबुद्ध है । सभी आचार्यों ने खुर शब्द से हाथ-पैर का साधर्म्य होने से ही ऐसा वर्णन दिया है ।

In this the fetus gets obstructed by its body presenting with head, hands and feet all together

३) बीजक (Bījaka)

यो निर्गच्छवेकशिरोभुजः स बीजकः । (सु० नि० ८/४)

जो एक भुजा तथा शिर के द्वारा निकलता है वह बीजक है । (चि० १०)

माधवनिदानदि पुस्तकों में दो भुजा तथा शिर का निकलना बीजक का लक्षण माना है । मधुकोष व्याख्या एवं भावप्रकाश के स्मृतीकरण में लिखा है कि दोनों भुजाओं के बीच में शिर कर्क निकलता हुआ काय या शेष शरीर से अटका हुआ गर्भ बीजक मूढगर्भ है । भोज के भी यही विचार है (चि० ११)

Fetus delivers by head alongwith one hand is the opinion of Suśruta. (fig 10) Mādhava etc. have mentioned that the fetus delivering with head situated in between both the hands gets obstructed by its remaining body. (fig 11)

४) परिध (Pariḍha)

यस्तु परिध इव योनिमुखमावृत्य तिष्ठति स परिधः । (सु० सं० नि० ८/४)

१. अ) दृश्यैः खुरैः प्रतिबुद्धः स हि कायसङ्गी । (मा० नि० ६४/६, भा० प्र० चि० ७०/११४ एवं यो० १० स्त्रीरोग चि० प्रतिबुद्ध के स्थान में प्रतिबुद्धः पाठ)

अ) दृश्यैः बहिर्गतेः । खुरैः-खुरसाधर्म्यात्खुराशब्देनात्र हस्तौ पालौ च गृह्यते । तेन हस्तद्वयपादद्वयबहिर्गतैः प्रतिबुद्धः स हि कायसङ्गी=हस्तपादेतत्कायेन सक्तो भवति । (भा० प्र० चि० ७०/११४ को व्याख्या)

२.१। पुष्टेयं योनां तथैवद्विपरीतेन दृश्यैर्हस्तपादशिरोभिः प्रतिबुद्धः, खुर साधर्म्यात्, खुलान्देन हस्तपादवृत्ते ।१। भोजोऽप्येतान्-अथस्तात् पादवृत्तौ नापि तथैवाङ्कुलतोऽपि वा । यो निःसृत्य मुखं योनेर्ध्वं प्रतिबुद्धस्तु सः ॥

(मा० नि० ६४/६ को मधुकोष व्याख्या)

३. गच्छेत्पुनरुदयशिराः स च बीजकाख्या ॥ (मा० नि० ६४/६, भा० प्र० चि० ७०/११४ एवं यो० १० स्त्रीरोग चि०)

४. अ) पुनरुदयशिराः=पुनरुदयमध्ये शिरो यस्या एतादृश, गच्छेत्=निःसृत । तच्छेषेण शरीरेण सक्तो भवति, स बीजकाख्याः ॥ (भा० प्र० चि० ७०/११४ को स्मृतीकरण)

अ)पुनरुदयोपहितं शिरो यस्या स तथापूरः सन् यो गच्छेत् स बीजकः कायसङ्गी । भोजोऽप्येतान्.....१। योनिद्वारातु निर्गच्छेद्यक्षकः सशिरोभुजः । तमाहुर्बीजकं नाम मूढगर्भाभिर्चिकित्सकाः ॥ (मा० नि० ६४/६ को मधुकोष व्याख्या)

जो गर्भ योनि मुख को परिध (अर्थात्पाद) की भाँति आवृत करता है वह परिध मूढगर्भ है । (चि० ९ अ) माधवकरादि आचार्यों ने भी महर्षि सुश्रुत का अक्षरशः पालन किया है । भोज ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं ।

In this position the fetus obstructs the passage just like an iron beam or rod used for shutting the doors. (fig 9A)

इ) हारीत संहिता-वर्णित दोषिक मूढगर्भों के लक्षण (Clinical features of doṣika mūḍhagarbhas as per Hārīta)

१) वातिक मूढगर्भ (Vātika mūḍhagarbha)

वातजन्य गर्भसंरोध में बस्ति-शूल, योनिद्वार का अवरोध, जठर-गर्जन (शब्द), अभ्यान, तोद, अङ्गों में द्रुतने सदृश वेदना तथा निद्रानाशान्ति लक्षण होते हैं ।

In the obstruction of fetus caused by vāta, the lady gets pain in the region of urinary bladder, obstruction to the vaginal passage, gurgling sound in the abdomen, flatulence, pain (in abdomen), breaking type of severe bodyache and insomnia.

२) पैतिक मूढगर्भ (Paitika mūḍhagarbha)

पित्तजन्य गर्भासंरोध में शूल, विदोषज ज्वर, तृष्णा-दोष, श्रम, मूत्रकृच्छ्र तथा शिरोवेदना होती है ।

In this condition the woman suffers from pain (in abdomen), fever caused by all the three doṣas (tridosaja jvara), thirst, giddiness, dysuria and headache.

३) रत्नैषिक मूढगर्भ (Ūśāṣmika mūḍhagarbha)

रत्नैषिक मूढगर्भ में आलस्य, तन्द्रा, निद्रा, आध्यान, वेपथु (कम्प), कास तथा मुखवैरस्य होता है ।

In this condition the lady has idleness, drowsiness, sleepiness, stillness, flatulence, tremors, cough and testlessness of mouth.

४) द्वन्द्वज एवं सन्निपातिक मूढगर्भ (Dvandvaja and sannipāṭik mūḍhagarbha)

द्वन्द्वज एवं सन्निपातिक मूढगर्भ में में दो दो दोषों अथवा सभी के लक्षण मिलते हैं ।

In these types of mūḍhagarbhas the clinical features of two doṣas or all the three doṣas will be evident.

विमर्श (Comments)

दोषिक मूढगर्भ की कल्पना केवल महर्षि हारीत ने की है महर्षि सुश्रुतादि ने इनमें से अधिकंश का समावेश मूढगर्भ

१. योनी स्थितः स परिधः परिधेण तुल्यः । (मा० नि० ६४/६, भा० प्र० चि० ७०/११४, यो० १० स्त्रीरोग चि०)

२. भोजोऽप्येतान्.....योनिमवृत्य यस्तिष्ठेत् परिधो गोपुर् यथा ।

तथाऽन्तर्गर्भायास्तं विधात् परिधसंज्ञितम् ॥ (मा० नि० ६४/६ को मधुकोष व्याख्या एवं यो० १० स्त्रीरोग चि०)

३. बस्तिशूलश्च भवति योनिद्वार निरुच्यति । गर्जते जठरं यस्या आध्यानश्चैव जायते ॥ ४ ॥

तोदने चाङ्गभङ्गश्च निद्राभङ्गश्च जायते । वाताद्भवति गर्भस्य संरोधो भिषगुत्तमः ॥ ५ ॥

शूलं ज्वरविदोषश्च तृष्णादोषो भ्रमस्तथा । मूत्रकृच्छ्रं शिरोऽग्निः स्फुटिततदोषो भूणस्य च ॥ ६ ॥

आलस्यतन्द्रानिद्रा च जाड्याध्यानं च वेपथुः । कासो विरसता चास्ये रत्नेषणा मूढगर्भके ॥ ७ ॥

द्वन्द्वश्च द्वन्द्वजं विधातस्त्वं स्यात्सन्निपातिकम् ॥ ८ ॥ (हो० सं० तृती० ५२/४ से ८)

लक्षणान्तर्गत (सामान्य अथवा असाध्यता में) किया है। लक्षणों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वातिक, पौतिक, एवं रसैषिक मूढगर्भ के लक्षण गर्भ में मूढ़ता होने के बाद क्रमशः तात्कालिक अथवा प्रारम्भिक, जलाभावादि के लक्षणों एवं क्लिबन्धित एवं कीटोन की उपस्थिति या अतिक्लिबन्धित स्थिति के शोक्त हैं।

Features of *mūḍhagarbha* caused by *dosas* are given by Hārta only, *Suśruta*^६ etc. have included these under general features or features of incurability. It appears that features of *mūḍhagarbha* due to *vāta*, *pitta* and *kapha* are the description of features of obstructed labour developing immediately after obstruction, after lapse of sometime having dehydration and after much delay having ketosis respectively.

ई) मूढगर्भ की गतिर्याँ (*Gaities or different presentations of mūḍhagarbha*)

तत्र कश्चिद् द्वाभ्यां सविश्रय्यां योनिमुखं प्रतिपद्यते, कश्चिदाभुनैकसविश्रयेकन, कश्चिदाभुनसविश्रयरीः स्फिग्देशेन त्रियगागतः, कश्चिदुःपार्ष्वपृष्ठानामन्यतमेन योनिद्वारं पिथयावतिष्ठते, अन्तःपार्ष्वापवृत्ताशिराः कश्चिदेकेन बाहुना, कश्चिदाभुनशिरा बाहुद्वयेन, कश्चिदाभुनमध्यो हस्तपादशिरोभिः, कश्चिदेकेन सक्राना योनिमुखं प्रतिपद्यतेऽपरेण पायुप, इत्यष्टविधामूढगर्भगतिरिष्टा समासेन ॥ (सु० सं० नि० ८/५)

कोई दोनों सक्थियों (जंघाओं से) से योनिमुख को प्राप्त होता है; कोई एक सक्थि मुड़ी हुई तथा दूसरी सक्थि से (प्रसवित होता है); कोई सक्थियों को शरीर के ऊपर आभुन करके स्फिग्देश से तिर्यक् रूप से आता है; कोई उर, पार्ष्व एवं पृष्ठ आदि अन्य अङ्गों से योनिमुख को आच्छादित करके उठता है; कोई शिर को (माता के) पार्ष्व की ओर कंके एवं पृष्ठ आदि अन्य अङ्गों से आभुन करके दोनों बाहुओं से; कोई मध्य में आभुन होकर हस्त, पाद एवं शिर से तथा एक बाहु से; कोई शिर को आभुन करके दोनों बाहुओं से; कोई मध्य में आभुन होकर हस्त, पाद एवं शिर से तथा कोई एक सक्थि से योनिद्वार तथा दूसरे से पायु (गुदा) द्वारा प्रसवित होता है। ये संक्षेप में मूढगर्भ की आठ गतिर्याँ हैं। टीकाकार डल्हन ने विस्तार में तिर्यग्, ग्रीवा, जंघा आदि अनेकों प्रकारों का उल्लेख किया है।

महर्षि सुश्रुत ने मूढगर्भ के पूर्ववर्णित (कीलकादि) चारों भेदों को विगुण वायु-जन्म उत्पन्न गतिर्यों की असंख्यता के कारण असम्यक् बताते हुए उपर्युक्त आठ गतिर्यों का वर्णन दिया है।^१ अष्टाङ्गसंग्रहकार ने प्रथम ऊर्ध्व, तिर्यक् एवं न्युब्ज तीन प्रकार की गतिर्यों का उल्लेख कर आठ संस्थानों का उल्लेख किया है।^२ एवं उन आठों को चिकित्सा वर्णन करते समय ही लिखा है।^३ टीकाकार इन्द्र ने सुश्रुतादि एवं चिकित्सान्तर्गत वर्णित विषय के आधार पर आठ गतिर्यों का उल्लेख किया है तथा ऊर्ध्व, तिर्यक् एवं न्युब्ज का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि ऊर्ध्व अर्थात् जिसमें गर्भ अत्यधिक ऊँचा हो जाय है तथा ऊर्ध्व, तिर्यक् एवं न्युब्ज का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि ऊर्ध्व अर्थात् जिसमें गर्भ अत्यधिक बड़े होने, (अर्थात् गर्भ का शिर या उदय होने वाला अङ्ग श्रोणिगुहा से अत्यधिक ऊँचा रहे जैसा कि शिर के अत्यधिक बड़े होने, श्रोणिगुहा के छोटे होने या शिर के सामान्य सङ्कोच के अनुपस्थित होने में देखा जाता है); तिर्यक्षीन अर्थात् गर्भिणी के पार्ष्वों में पाद एवं शिर हों या अनुपस्थ आसन्; तथा न्युब्ज अर्थात् शिर नीचे एवं पैर ऊपर (न्युब्ज के अर्थ के आधार पर यह वर्णन उचित प्रतीत नहीं होता, शिर नीचे की स्थिति सामान्य होती है, न्युब्ज अर्थात् पृष्ठशय से अवरोध)। इस गर्भ के आठ संस्थान होते हैं, उन्हें कहा जाता है, दोनों सक्थियों से आता हुआ पहिला, एक सक्थि से आता हुआ दूसरा, सिम्पल-मूल से आता हुआ तीसरा, तिर्यक् चौथा, पार्ष्वापवृत्त शिर पाँचवा, दोनों बाहुओं से आता हुआ छठवाँ, पीठ को

१.१। विस्तरेण तु तिर्यग्ग्रीवोऽङ्गप्रकारोऽनन्तः ॥ (सु० सं० नि० ८/५ को डल्हन टीका)
२. इति चतुर्विधो भवतीत्येके भाष्यते । तत् तु न सम्यक् । कस्मात् ? स यदा विगुणनित्यप्रीडितोऽपत्यप्रयमनेकया प्रतिपद्यते तदा सङ्ख्या होयते ॥ (सु० सं० नि० ८/४)
३. समस्तसत्सु त्रिविधा गतिर्यथा तिर्यङ्न्युब्जा च । संस्थानानि पुनरष्टौ । तान्यनैवोत्तर वक्ष्यते ॥ (अ० सं० शा० ४/३०)
४. अ० सं० शा० ४/३९ (चिकित्सान्तर्गत वर्णित)

टेढ़ी करके हाथ, पैर एवं शिर से आता हुआ सातवाँ तथा एक पैर-से योनि तथा दूसरे से गुदा में आता हुआ आठवाँ (संस्थान या गति है)।

माधवनिदान में आठ गतिर्याँ इस प्रकार हैं, कोई द्वार (योनि) को शिर के द्वारा, कोई जवर के द्वारा, कोई परिवर्तित शरीर होकर कुब्ज देख से, कोई एक भुजा से, कोई दोनों भुजाओं से, कोई त्रियगाति अर्थात् अर्गला की भाँति होकर योनिमुख को रोककर, कोई अवाङ्मुख हो योनि को रोक कर तथा कोई पार्ष्वापवृत्तागति अर्थात् पार्ष्वभङ्ग या पार्ष्व का संकोच हो विगुण होकर योनि मुख को रोकता है। ये मूढगर्भ की आठ गतिर्याँ हैं।^३

भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर में माधवनिदान तथा सुश्रुत दोनों में ही वर्णित आठों गतिर्यों का उल्लेख है।

चिकित्सान्तर्गत महर्षि वाग्भट द्वारा उद्धृत संस्थान तथा सुश्रुत वर्णित गतिर्यों में विशिष्ट मतभेद नहीं है। परन्तु माधवनिदान के वर्णन में कुछ भिन्नता प्रतीत होती है। अतः इन आचार्यों द्वारा वर्णित गति या संस्थानों को तालिका-१० में दिया जा रहा है। इन गतिर्यों में ही पूर्व वर्णित कीलकादि चारों भेदों का भी समावेश हो जाता है।

तालिका-१०

गति या संस्थान	सु०	अ० सं०	मा० नि०
१) दोनों सक्थियाँ	+	+	-
(अपूर्ण) स्फिक्कासन में दोनों सक्थियों से उदय या पादोदय) (चि० ८ अ)			
२) एक सक्थि आभुन एक से उदय	+	+	-
(अपूर्ण) स्फिक्कासन में एक सक्थि का उदय या पादोदय) (चि० ८ ब)			
३) सिम्पल देश से	+	+	-
(स्फिक्कासन में स्फिग्गुदय; भेदों में वर्णित कीलक या संकीलक) (चि० ८ स एवं द)			
४) उर, पार्ष्व, पृष्ठदि	+	-	-
(अनुपस्थ आसन के विभिन्न उदय; भेदों में वर्णित पथि) (चि० ९ अ)			
५) अन्तःपार्ष्वापवृत्त शिर एवं एक भुजा	+	+	+

१. ऊर्ध्वं यस्यामुत्थितो गर्भ आयाति, तिर्यक्षीना गर्भिणीपार्ष्वयोः कृतपादशिरसः। न्युब्जा अधशिरस ऊर्ध्वपादस्य। तस्य च गर्भस्यायस्य संस्थानानि तानि च वक्ष्यते। सक्थिप्रयामागमनेकम्। एकेन संस्थाना द्वितीयम्। स्फिङ्गुमूलेन तृतीयम्। तिर्यक् चतुर्थम्। पार्ष्ववृत्ताशिरसः पञ्चमम्। बाहुद्वयेन षष्ठम्। वक्षेण पृष्ठेन पाणिपादाशिरसा योनिमुखगमनं सप्तमम्। एकेन पादेन योनि द्वितीयेन गुदमित्यष्टमम् ॥ (अ० सं० शा० ४/३० को इन्द्र टीका)

२. द्वारं निरुध्वा शिरसा जठरेण कश्चिद्, कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जदेहः ॥ ४॥

एकेन कश्चिदपरस्य पुञ्जद्वयेन, त्रियगातो भवति कश्चिदवाङ्मुखोऽयम् ॥

पार्ष्वापवृत्तागतिरिति तथैव कश्चिदित्यष्टधा गतिरियं ॥ ५॥

(...त्रियगात इति अर्गलायमानः।पार्ष्वापवृत्तागतिरिति पार्ष्वभङ्गेन विगुणीकृतः पार्ष्वत इति पाद-मधुकोष व्या०) (मा० नि० ६/४४, ५)

३. अ) द्वारंपरिवर्तितकुब्जकायः। एकेनअष्टधा भवति गर्भगतिः प्रसूतौ ॥ १९५॥

(अन्य माधवनिदान सदृश ही)

कश्चिद् द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रतिपद्यते। कश्चिदाभुनैकसक्थिरतिरेण सक्राना ॥

कश्चिदाभुनसक्थिशरीरः स्फिक्देशे त्रियगातः। कश्चिदुःपार्ष्वपृष्ठानामन्यतमेन योनिद्वारं पिथयावतिष्ठते।

अन्यः पार्ष्वपावृत्ताशिराः कश्चिदेकेन बाहुना। कश्चिदाभुनशिरा बाहुद्वयेन। कश्चिदाभुनमध्यो हस्तपादशिरोभिः ॥

कश्चिदेके सक्राना योनिद्वारं प्रतिपद्यते अपरेण पायुमिति ॥ (पा० प्र० चि० ७०/१५५)

आ) यो० र० स्त्री० ते० चि० (भावप्रकाश सदृश ही)

गति या संस्थान	सु०	अ०	सं०	मा०	नि०
(अनुप्रस्थ आसन अथवा शीर्षोदय में हस्त बहिर्निर्मित; भेदों में सुश्रुत-वर्णित बीजक) (चि० १०)					
६) आभुन शिर एवं दोनों बाहु	+	+	+	+	
(शीर्षोदय में दोनों भुजाओं का उदय या मिश्रित उदय; भेदों में माधवादि वर्णित बीजक) (चित्र ११)					
७) हस्तपाद एवं शिर सभी से उदय	+	+	+	-	
(अनुप्रस्थ आसन में अत्यधिक संकोच हो उपर्युक्त उदय; भेदों में वर्णित प्रतिबुद्ध) (चि० १२)					
८) एक पैर योनि एवं एक पायु में	+	+	+	-	
(सिकासन के पादोदय में गर्भाशय एवं गुदा का विदार) (चि० १३)					
९) शिर से अवरोध	-	-	-	+	
(विकृत शीर्षोदय या श्रोणिगुहा संकोच) (चि० १४ अ एवं ब)					
१०) अवाङ्गमुख (मुखोदय) (चि० १५)	-	-	-	+	
११) जठर (अनुप्रस्थ आसन में उदरोदय या नालोदय) (चि० १ ब)	-	-	-	+	
१२) शरीर परिवर्तित एवं कुब्जदेह	-	-	-	+	
(अनुप्रस्थ आसन में अतिसंकोच एवं पृष्ठोदय) (चि० १६)					
१३) त्रिवर्गागत या अर्गला सदृश	-	-	-	+	
(अनुप्रस्थ आसन में गर्भ-संकुचन-विहीनता; भेदों में वर्णित परिध)					
१४) पार्श्वोपवृत्त	-	-	-	+	
(अनुप्रस्थ आसन में पार्श्वोदय)					

नोट—महर्षि सुश्रुतेक नं० ४ की ही गति में माधवनिदान वर्णित अन्तिम चार (११ से १४) गतियाँ अन्तर्भूत हो जाती है। नं० ५ की वर्णित गति में वाग्भट ने पार्श्वोपवृत्तशिर तो लिखा है पर भुजा का उल्लेख नहीं किया। माधवप्रकाश तथा योगरत्नाकर पुस्तकों में सुश्रुत तथा माधवनिदान दोनों के ही वर्णन मिलते हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने सामान्य वर्णन या विकृति में कहाँ पर भी मूढगर्भ की किन्हीं गतियों का उल्लेख नहीं किया परन्तु सुश्रुतेक अन्तिम दोनों गतियों को विक्रम्य नाम से लिखा है यथा—

हस्त, पाद एवं शिर से जो गर्भ योनिमुख में अवतीरित होता है अथवा जिसका एक पैर योनि एवं दूसरा गुदा मार्ग से निकला होता है वे दोनों ही विक्रम्य नाम से कहे जाते हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने हाथ अथवा पैर अथवा शिर के भुन या कुटिल (असामान्य) रूप से योनि में प्राप्त हुए मूढगर्भ को पहिला विक्रम्य तथा भुन रूप से एक पैर से योनि एवं दूसरे से गुदा में प्रतिपादित गर्भ को दूसरा विक्रम्य माना है^१।

Suśruta after writing *kila* etc. four types has explained that this classification is not proper because the fetus has multiple presentations, thus has further described eight *gaies*. Dalhana says that even these eight *gaies* are a summarized description, for detailed under-

१. हस्तपादशिरोभ्यां योनिं भुनः प्रपद्यते । पादेन योनिमेकेन भुनोऽन्येन गुदं च यः ॥ २९॥

विक्रम्यौ नाम तौ मूढौ ॥ ३०॥

(कदाचिदस्तेन कदाचिच्छिस्तं, योनिं प्रतिभुनः-कुटिलः, प्रपद्यते-आयाति, यः स एको विक्रम्यो नाम मूढगर्भः । तथा पार्श्वैकेन योनिं तथा द्वितीयपादेन गुदं-पादु, भुनः सत् यो मूढगर्भः प्रपद्यते, सोऽप्यो विक्रम्यः-अन्यो टीका) (अ० ह० शा० २/२९, ३०)

standing *tiryak* (transverse), *grīvā* (neck), *janṅhā* (thigh) etc. various more presentations can be envisaged. Three *gaies* or mode of fixations i. e. *ūrdhwa*, *tiryaka* and *nyūḍja* described by Vāgbhata I have been clarified by Indu i. e. *ūrdhwa* or in which fetus remains very high up (as seen in marked cephalopelvic disproportions or extension of head), *tiryaka* in which head and feet are situated in both flanks of the woman (transverse lie) and *nyūḍja* in which head is downwards and foot upwards (considering the verbal meaning of *nyūḍja* i. e. hump-backed Indu's explanation does not seem to be proper, probably it refers to dorso-anterior position of transverse lie). Vāgbhata describing eight presentations has used the word *samsthāna*. There is great difference in eight *gaies* described by Mādhavanidāna and Suśruta etc. In Bhāwaprakāśa and Yogaratnākara the description of Suśruta and Mādhava both the authors is given.

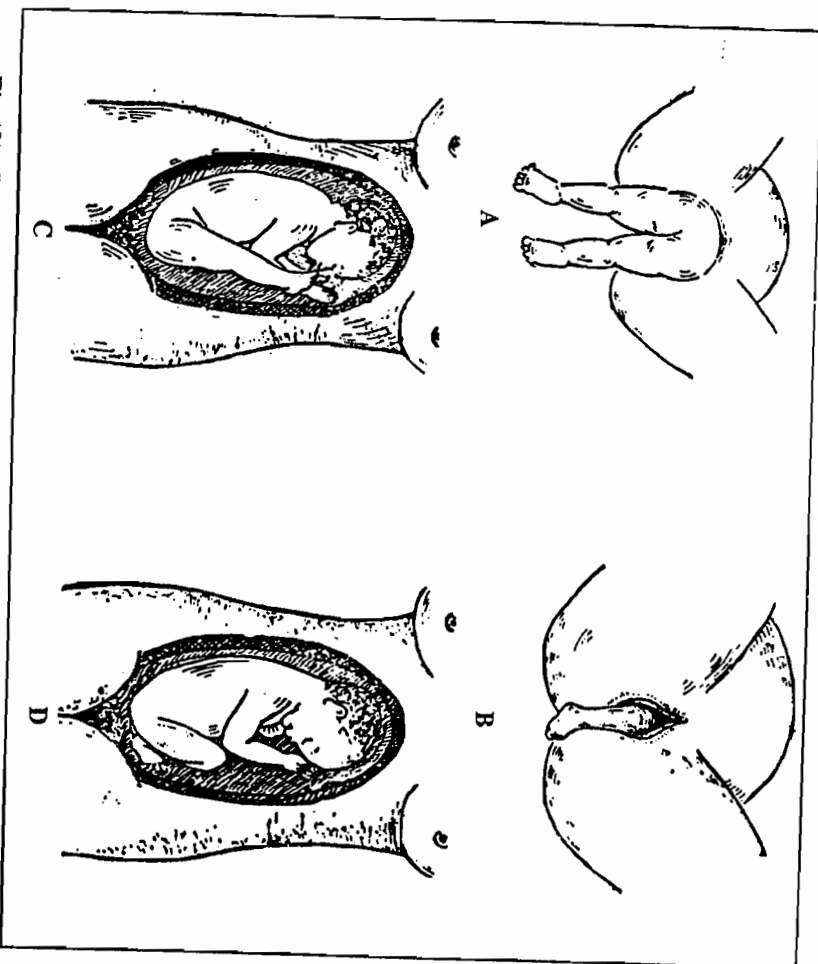


Fig (8) : Different presentations of *sphingudaya* or breech presentation. (A) Pre-senting with both the legs or footings presentation in incomplete breech; (B) Presenting with one leg or footling presentation in incomplete breech; (C) Presenting with buttocks in incomplete breech with extended legs or *kila* (D) Complete breech.



Fig (9) : (A) *Prithodaya* or shoulder presentation in dorso-anterior position of transverse lie or *parigha*; (B) *Jatharodaya* or having cord prolapse.

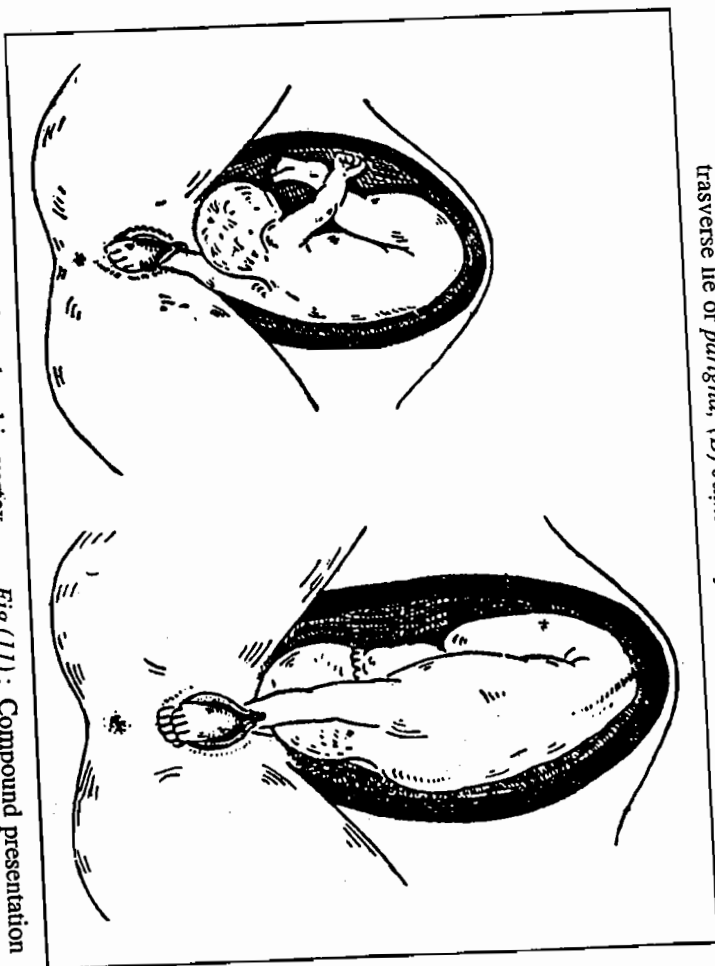


Fig (10) : Prolapse of one hand in vertex presentation or *bijaka*. Note head is deflexed.

Fig (11) : Compound presentation presenting with head and both hands or *bijaka*.



Fig (12) : Exaggerated flexion of fetus in transverse lie; the fetus presents with both the hands, legs and head together or *pratikhuira*.

Fig (13) : In delayed footlings presentation one foot is presenting through vagina, while other through anus after perforating the colon or rectum.

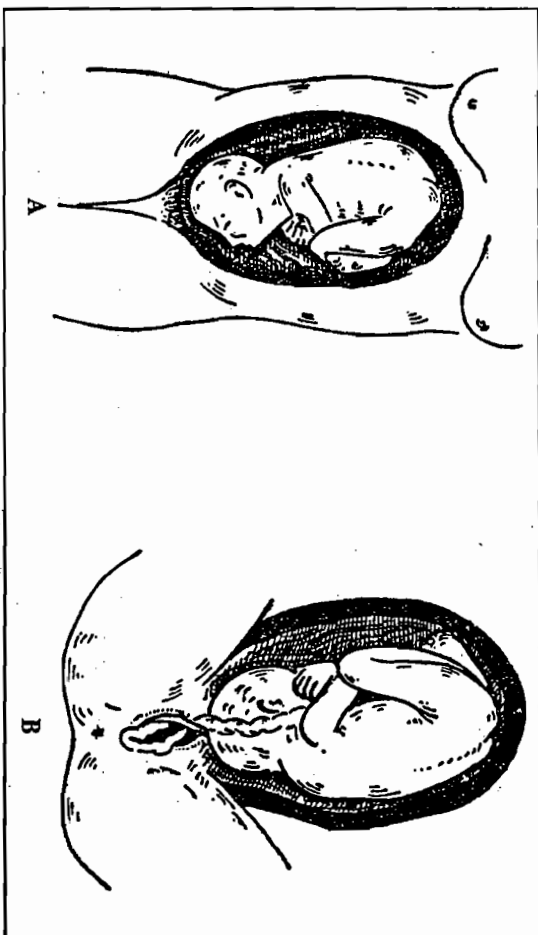
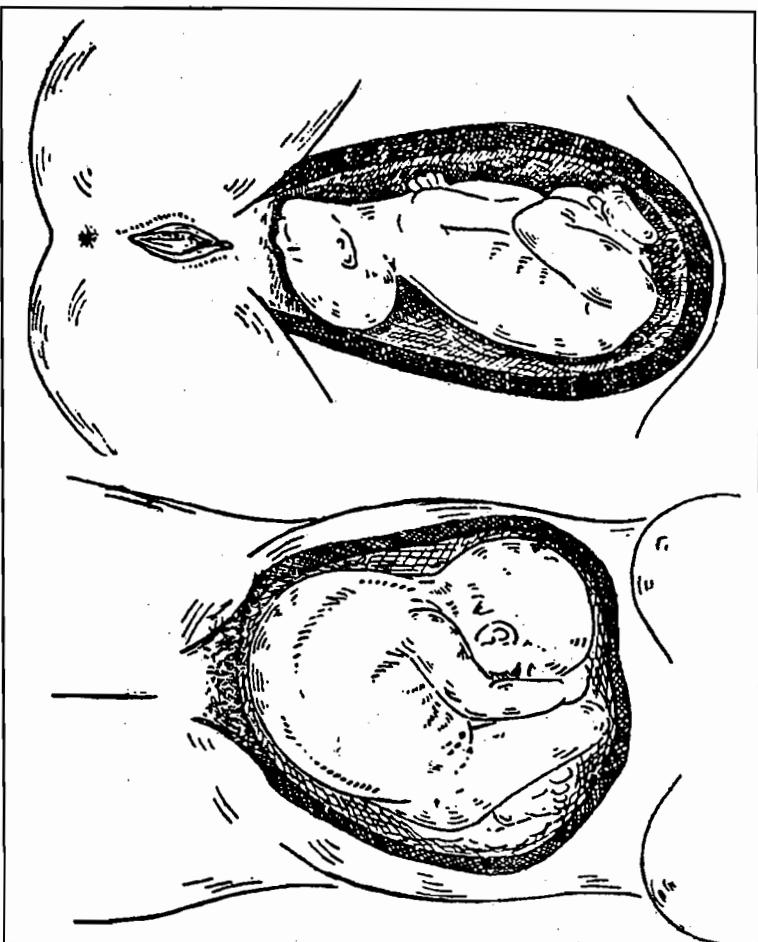


Fig (14) : Obstruction by the *sira* (head). (A) The progress is obstructed due to deflexion of head in brow presentation or (B) Non-engagement of head with prolapse of cord in contracted pelvis.

Fig (15) : Obstruction to delivery by *mukha* (face presentation).Fig (16) : Presenting with *kubjaleha* (hump back) in dorso-anterior position with flexed back.

Different *gaies* (positions/presentations) described by all these authors are being given in tabular form. These *gaies* include *kīlaka* etc. four types described earlier.

<i>Gai or Sansthāna</i> (position/presentation)	S.S.	A.S.	M.N.
1	2	3	4
1. Both the <i>sakthies</i> or presenting with both the thighs or footlings presentation in incomplete breech (fig. 8A)	+	+	—

	1	2	3	4
2. One <i>sakthi ābhugna</i> and <i>udaya</i> by the other or one thigh presenting other flexed or footling presentation in incomplete breech (fig. 8B).	+	+	—	—
3. <i>Sphigdeśa</i> or presenting with buttocks in incomplete breech with extension of legs (<i>kīlaka</i>) or complete breech (fig. 8c and D)	+	+	—	—
4. <i>Ura, pārśwa, prīṣṭha</i> or chest, flanks, back etc. presentations of transverse lie in dorso-posterior and dorso-anterior position (<i>parigha</i>) (fig. 9A).	+	—	—	—
5. <i>Anahpārśwāparyāṣṭra</i> and delivering with one <i>bhujā</i> or head situated in flanks and delivery with one hand i. e. hand prolapse in transverse lie or in vertex presentation (<i>bījaka</i> according to Suśruta.) (fig 10)	+	+	+	+
6. <i>Ābhugna śīra</i> and both the <i>bhujā</i> or flexed head with both hands or compound presentation (<i>bījaka</i> described by Mādhava etc). (fig 11)	+	+	+	+
7. <i>Hasta, pāda</i> and <i>śirodaya</i> or presenting with both hands, legs and head together in exaggerated flexion of transverse lie (<i>pratikūra</i>). (fig 12)	+	+	—	—
8. One foot in <i>yoni</i> (vagina) and other in <i>pāyu</i> (anus) or rupture of lower uterine segment along with perforation of colon or rectum. (fig 13)	+	+	—	—
9. Obstruction by <i>śīra</i> or abnormal vertex as POP, brow presentation (fig 14 A) or in contracted pelvis. (fig 14B)	—	—	—	+
10. <i>Āwāṅgamukha</i> or face presentation. (fig 15)	—	—	—	+
11. <i>Jajhara</i> or dorso-posterior position and abdomen presentation of transverse lie or cord presentation. (fig 9B)	—	—	—	+

1	2	3	4
12. <i>Parivartita śāra</i> and <i>kubjadela</i> or body rotated and presenting with humpback. Dorso-anterior flexed back in transverse lie. (fig 16)	—	—	+
13. <i>Tiryagāgā</i> like <i>argala</i> or transverse lie without flexion of fetal body.	—	+	+
14. <i>Pārsvāparyā</i> or presenting with flanks or lateral delivery in transverse lie.	—	—	+

Note—Presentation described by Sūśruta under No. 4 includes last four presentations of Mādhavanidāna. In No. 5, Vāgubhāta has mentioned position of head only but not prolapse of hand. Vāgubhāta II has mentioned only two i. e. No. 7 and 8 mentioned above by the name “*viskambha*”

असाध्य मूढगर्भ के लक्षण (Clinical feature denoting incurability of mūḍhagarbha)

गर्भकोषपरासङ्गो मक्कल्लो योनिर्नस्यतिः । इत्यात् स्त्रियं मूढगर्भे यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥
(सु० सं० सू० ३३/१३)

तत्र द्वावन्त्यावासयो मूढगर्भा । शेषेणानपि विपरीतेन्द्रियाश्लेषकं वाताविकार-पादटीका योनिभ्रंशसं-
रणमक्कल्लश्वासकासप्रमनिपीडिताम् परिहेत् ॥ ६ ॥

प्रविध्यति शिरो या तु शीताङ्गी नित्यप्रवा । नीतोद्धतसिरा हन्ति सा गर्भं स च तं तथा ॥ ११ ॥
(सु० सं० नि० ८/६ व ११)

द्वावन्त्यावासयो मूढगर्भा ॥ (सु० सं० वि० १५/१)
तेषु सर्वेष्वपि विपरीतेन्द्रियाश्लेषयोनिभ्रंशसंवरणमक्कल्लश्वासप्रमभिपन्नां शीतगान्नां पूर्युद्गारां च
वर्जयेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/३१)

योनिर्नस्यति योनिर्नस्यति । पूर्युद्गारां हिमाङ्गी च मूढगर्भा परित्यजेत् ॥
(अ० ह० शा० २/३८)

पूतिगन्धि मुखं यस्याः शूलं चैवोपजायते । निद्रा चाऽपि म्रत्युत्वेनां मूढगर्भा न जीवति ॥ १६८ ॥
मयूरीवसंकाशं या पश्यति हुताशनम् । शून्यादमुखी चैव मूढगर्भा न जीवति ॥ १६९ ॥
रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना । स्मरते सा शयाना वा रमणानं चाऽधिशेहति ॥ १७४ ॥

मूढगर्भा सर्गार्थं वा गर्भिणी सा विनश्यति ॥ १७५ ॥ (का० सं० छिन्न १०)
मूढगर्भं मे गर्भकोष-परासङ्ग, मक्कल्ल, योनिर्नस्यति आदि तथा अन्य वर्णित (नि० स्थान वर्णित) उपद्रव स्त्री का हनन कर देते हैं । टीकाकार डल्हण ने गर्भकोषपरासङ्ग के दो अर्थ दिये हैं गर्भाशय का अत्यधिक आसङ्ग या निरोध तथा गर्भ का स्वस्थान से परस्थान में जाकर सङ्ग या निरोध; मक्कल्ल पूर्ववर्णित (१० ४७०) है; योनिर्नस्यति अर्थात् योनि-संकोच तथा आश्लेषक, कास, श्वास, भ्रम आदि मूढगर्भ निदानाख्याय वर्णित लक्षण होने पर वह मूढगर्भ स्त्री का

हनन कर देता है ।

पुनश्च महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि दोनों अन्त के (सालावों एवं आलावों गति वाले अर्थात् हाथ, पैर एवं शिर से एक साथ प्रसवित तथा एक पैर योनि एवं दूसरा पायु में) मूढगर्भ असाध्य है । शेष मूढगर्भों में भी विपरीतेन्द्रियार्थ अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अपने कार्य में वैषम्य यथा रूपादि के ग्रहण में भ्रम, आश्लेषक, वाताविकार, योनिभ्रंश, (योनि) संवरण, मक्कल्ल, श्वास, कास, एवं भ्रम से पीडित स्त्री का परित्याग करना चाहिए ।

जो स्त्री अपने शिर को बार बार घुमती या कूटती है, जिसके अङ्ग शीतल हो गए हैं, लज्जा स्मिहित हो गई है, नीली-नीली शिराओं उभर गई हैं वह स्त्री उस गर्भ को तथा वह गर्भ उस स्त्री को नष्ट कर देता है । यद्यपि यह श्लोक गर्भशलावादि के वर्णन के बाद उल्लिखित है एवं सीहिता में इन लक्षणों के मूढगर्भ की असाध्यता के लिए वर्णित होने का निर्देश नहीं है पर टीकाकार डल्हण ने इन्हें असाध्य मूढगर्भ के लक्षण होने का स्पष्ट निर्देश दिया है एवं 'प्रविध्यति' के पाठान्तर में 'अपविद्धशिरा' अर्थात् अवनत शिर वाली या शिर को धारण करने की शक्ति से विरहित स्त्री का वर्णन दिया है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि इन सभी (मूढगर्भों या मूढगर्भों) में विपरीतेन्द्रियार्थ, आश्लेष, (योनि) भ्रंश, योनि-संवरण, मक्कल्ल, श्वास, भ्रम आदि से पीडित, शीताङ्गी वाली तथा पूतिगन्धि से युक्त उद्गार वाली स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए ।

अष्टाङ्गहृत्यकार ने भी लिखा है कि योनिर्नस्यण, (योनि) भ्रंश, मक्कल्ल तथा श्वास से पीडित, पूर्युद्गार-युक्त, शीत-गाना स्त्री का परित्याग करना चाहिए ।

महर्षि काश्यप ने मूढगर्भ के अष्ट लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस मूढगर्भ वाली स्त्री के मुख से पूति गन्धि आती हो, जिसे शूल उत्पन्न हो जाय तथा सदा नींद आती रहती हो वह जीवित नहीं रहती ।

जो मूढगर्भ स्त्री अग्निको मयूरी-प्रीवा-सदृश (नीले वर्ण की) देखती है, जिसके पैर एवं मुख सूखे हुए हैं वह जीवित नहीं रहती ।

जो मूढगर्भ स्त्री रक्त वर्ण के वस्त्र पहिन्ती है, रक्त वर्ण की मालाएँ अथवा अन्य अनुलेपन प्रयोग करती है, सोते समय मुस्कलाती है अथवा रमणान की ओर जाती है वह जीवित नहीं रहती है ।

महर्षि हारीत ने भी सम्भवतः महर्षि सुश्रुत के ही वर्णन का अनुकरण किया है । श्लोक की पहिली लाइन अशुद्ध प्रतीत होती है । फिर भी वास्तविक वर्णन के आधार पर निम्न अर्थ कर सकते हैं—गर्भकोष के आपन होने पर (गर्भाशय के विकार युक्त होने पर), मण्डुख या मशर (गति) वाला होने पर (गर्भाशय की संकुचन क्रिया अत्यधिक कम होने पर) तथा योनि में सङ्ग होने पर (योनिपथ में आकर पथ की संकीर्णता के कारण रक्तावट होने पर) तथा अग्रे वर्णित अन्य उपद्रवों की उपस्थिति में मूढगर्भ स्त्री को मार देता है ।

१.गर्भकोषपरासङ्ग इति गर्भाशयस्य परः श्रेष्ठ आसङ्गोऽतिशयेन निरोध इत्यर्थः; अन्ये तु स्वस्थानात् परस्थानं गत्वा गर्भस्य सङ्गो निरोध उत्पद्यते, अनेन प्रकारेण परासङ्ग इति कथयन्ति । मक्कल्ल इति गर्भिणीव्याकरणको श्रेयः, तत्राप्रजातायशेति चकातावकेवत् प्रजातायाः, अप्रजाताया अपि मक्कल्लो भवति, तथा गर्भाशयाभ्युत्थानाभ्या योनिद्विस्तारकमप्याश्रय रक्तं सुतमनःस्थितं पच्यमानं मक्कल्लसंज्ञं भवतीति ज्ञेयम् । योनिर्नस्यतिः योनिमसङ्गत्वम् । यथोक्ताश्चाप्युपद्रवा इति आश्लेषकासश्वासप्रमदयो मूढगर्भनिदाने पठितः ॥ (सु० सं० सू० ३३/१३ को डल्हण टीका)

२. असाध्यमूढगर्भार्थिर्न्योर्लक्षणं दर्शयग्राह.....अन्ये 'अपविद्धशिरा' इति पठन्ति तत्रावनतशीर्षेत्यर्थः ॥ (सु० नि० ८/११ को डल्हण टीका)

३. तेषु सर्वेष्वपि मूढगर्भेषु..... (अ० सं० शा० ४/३१ को इन्दु टीका)

४. गर्भकोषसमापन्नो मुकष्टो (मुकष्टो-शु० पा०) योनिर्नस्यतिः ।

इति स्त्रियं मूढगर्भं यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ (हो० सं० हि० स्या० ४/४१)

माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर में भी लिखा है कि शिर को धारण करने में असमर्थ या अवनत शिर वाली, शीतलङ्गी, लज्जा-शून्य, कुक्षि में नील वर्ण की शिराओं से युक्त स्त्री गर्भ को तथा वह गर्भ उस स्त्री को नष्ट कर देता है तथा योनिसेवरा, कुक्षि-सङ्ग (योनिसेवरा जन्म प्रकुपित वायु से गर्भाशय में रुका हुआ गर्भ) तथा मक्कल एवं अन्य उपद्रवों से पीड़ित मूढगर्भा स्त्री जीवित नहीं रहती^१।

In the presence of *garbhakosaparsāṅga*, *makkalla* and *yonicanvṛti* the *mūḍhagarbha* becomes incurable. Last two (i.e. seventh and eighth *gatis* described earlier) are also incurable. Other varieties of *mūḍhagarbha* when associated with hallucination or perception of non-existent or opposite things by sensory organs, convulsions, disorders of *vāta*, *yonicbhrāṃśa* (prolapse of uterus), *yonicanvāraṇa*, *makkalla*, *śwāsa* (dyspnoea), cough and giddiness should also be left or should not be treated.

The woman who is unable to hold her head or strikes her head repeatedly, whose body is cold, has become shameless and blue vessels have appeared over her abdomen, she kills her fetus and fetus kills her. Both Vāgubhāṣas have mentioned presence of foul smell in breath also as a sign of incurability.

Kaśyapa has given entirely different description in following way—

A woman with obstructed labour (*mūḍhagarbha*) having foul smell in breath, severe pain in abdomen and over-sleepiness does not survive.

A woman with *mūḍhagarbha* who sees the fire just like neck of a peacock (blue in colour), whose feet and face are swollen does not survive.

The woman having *mūḍhagarbha*, if wears red garments and garlands, uses red anointments, smiles during sleep and goes towards cremation ground (in dream) does not survive.

Hārta opines that if the *garbhakosa* is *āpanna* (uterus is diseased), fetus has slow progress (due to ineffectual uterine contractions) or there occurs *yonicāṅga* (obstruction to the labour due to constriction of *yoni* or pelvis) then also the *mūḍhagarbha* is incurable.

Mādhavanīdāna, Bhāvaprakāśa and Yogratnākara etc. books also have expressed similar views.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर असाध्य मूढगर्भ के लक्षणों को मुख्यतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं अपत्यपथ विकार-जन्म तथा सार्वदैहिक विकार-जन्म। यद्यपि महर्षि सुश्रुत ने गर्भ की दो स्थितियों (सातवीं एवं आठवीं गति) को भी असाध्य माना है पर चिकित्सानर्थात इन्हीं गतियों में शस्त्रकर्म करने का निर्देश दिया है, अतः यहाँ पर असाध्यता का

१. अपचिद्धशिरा या तु शीतलङ्गी निपत्यथा । निलोद्वर्तिसिरा हन्ति सा गर्भं स च तं तथा ॥

(अपचिद्धशिरा शिरा धारयितुमशक्तत्वर्थः, अवनतीशिरा इति गदाधरः ।। नीलोद्वर्तिसिरा इति नीलवर्णा उद्वर्ता सिरा

कुक्षौ यस्याः सा-मुषकोष टीका)

योनिसेवराय सङ्गः कुक्षौ मक्कल एव च । हन्युः स्त्रियं मूढगर्भा यथोकाश्चाप्युपद्रवाः ॥

(सङ्गः कुक्षोवृत्ति योनिसेवराय प्रतिनिधित्वे वायुर्गर्भाशयं यदा निलगच्छति तदा गर्भः कुक्षौ संको पवति स उच्यते-सङ्गः

कुक्षोवृत्ति । -मुषकोष व्याख्या)

(मा० नि० ६४/७ व १० तथा मुषकोष व्याख्या, मा० प्र० नि० ७०/११६ व १११ एवं योग १० स्त्री० १० वि०)

अर्थ हस्ताग्रहरण या मन्त्रादि से चिकित्सा-असाध्यता क-ना अधिक उचित होगा। अपत्यपथ एवं सार्वदैहिक विकारों का स्पष्टीकरण निम्नाङ्कित है।

अ) अपत्यपथ-विकार

१) गर्भकोष-परासङ्ग या गर्भकोष की आपन्नता-गर्भकोष-परासङ्ग शब्द की इच्छा-व्याख्या पूर्व वर्णित है। गर्भकोष या गर्भाशय का अत्यधिक सङ्ग अर्थ अधिक युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि 'पर' शब्द का अर्थ 'अन्य' होता है न कि 'अधिक'। गर्भकोष से अन्यत्र सङ्ग होने के लिये गर्भकोष का विदूरित होना आवश्यक है। मोनियर विलियम ने अपने शब्द कोष में 'परासङ्ग' को एक शब्द मान कर इसका अर्थ "क्लीविंग" भी किया है जिसका तात्पर्य 'दो में विभक्त होना' या 'विदूरित होना' आदि भी होता है अर्थात् गर्भकोष या गर्भाशय का विदूर अर्थ भी लिया जा सकता है। अवरुद्ध प्रसव में होने वाला गर्भाशय-विदार रूपा उपद्रव आज भी यदि असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है अतः यहाँ पर गर्भकोष-परासङ्ग से गर्भाशय-विदार ग्रहण करना अधिक युक्तिसङ्गत होगा।

महर्षि हारता ने गर्भकोष के आपन्न होने का वर्णन दिया है, यह आपन्नता तात्कालिक गर्भाशय-विदार के रूप में अथवा गर्भाशय के जन्मजात विकारों यथा यूटेरस आक्युइटस, डाइडेल्टिकस, सेपेट एवं बाद के विकारों यथा गर्भाशय के मांसवृद्ध के रूप में हो सकती है। इन सभी स्थितियों में मूढगर्भ का शस्त्र द्वारा ही आहरण सम्भव होता है अतः यदि वह असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य तो होता ही है।

२) मक्कल-यद्यपि सूत्रस्थान ३३/१३ की टीका में इच्छा ने अपन्नता (गर्भिणी) में गर्भाशय के अन्दर रक्त के एकत्रीकरण का वर्णन किया है परन्तु निदान ८/६ की टीका में प्रसूता में उत्पन्न वायु द्वारा अवरुद्ध रक्त-जन्म शूल लिखा है जो समुचित नहीं है क्योंकि मूढगर्भा स्त्री के असाध्यता के लक्षणों में प्रसव हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। टीकाकार आठमल्ल ने वायु एवं रक्त से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट शूल मक्कल के दो भेद दिए हैं (१) गर्भावस्था में (२) सूतिकावस्था में। मानसिक एवं आगन्तुज व्याधियों से पीड़ित गर्भ कुक्षि में वेदना उत्पन्न कर देता है, वह गर्भ-मक्कल है। यद्यपि मक्कल सामान्य रूप से प्रसूता के प्रसवोपरांत होने वाले शूल का वर्णन है परन्तु मूढगर्भा में मक्कल प्रसव-पूर्व रक्त-जन्म शूल या गर्भाशय की मांसपेशियों के अत्यधिक या असामान्य संकोच-जन्म-शूल का द्योतक है क्योंकि प्रसूता में शूल की उत्पत्ति पेशी-संकोच के ही कारण होती है। गर्भाशय-पेशी का अत्यधिक या असामान्य संकोच अथवा प्रसव-पूर्व रक्तसाव अवरुद्ध-प्रसव की चिकित्सा में बाधक होता है।

३) योनिसेवृत्ति या योनिसेवरा-यद्यपि महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने योनिसेवरा या सेवृत्ति अर्थात् योनि-संकोच का नामोल्लेख तो किया है पर इस व्याधि के लक्षणों का कहीं उल्लेख नहीं किया। मुषकोष-व्याख्या, भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर पुस्तकों में विशिष्ट वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है—

वातल अनपान, मैथुन और प्रजागरण का अत्यधिक सेवन करने वाली गर्भिणी स्त्री की योनिमार्ग स्थित वायु प्रकुपित होकर योनिद्वार को संकुचित कर देती है। मार्ग (योनिमार्ग) का अवरोध करके पुनः (वही) वायु अन्दर जाकर आशय (गर्भाशय) के द्वार का अवरोध कर उसके (गर्भाशय के) अन्दर स्थित गर्भ को पीड़ित करती है जिससे गर्भ का मुख एवं श्वास अवरुद्ध हो जाने से वह शोष ही मर जाता है। (वह प्रकुपित अनर्थात वायु) गर्भिणी स्त्री के हृदय प्रदेश को

१. सर यम्, मोनियर विलियम शब्द कोष (पृष्ठ ५८८)

२. प्रसूताया वायुरस्य आरोध वरितिशिःअपुनितु शूल करोति स मक्कलः ॥ (शु० सं० नि० ८/६ इच्छा टीका)

३. मक्कल इति । मक्कलतो रक्तमातलवः शूलविशेषः । स द्विविधो भवति । एको गर्भान्वास्याम्, अपरः सूतिकावस्थायाम् इति । तद्यथा ममसानुगुणितस्यतयोः प्रणीतिलो यो गर्भः कुक्षौ वेदनां जनयति स गर्भमक्कलः ॥ (शा० सं० पूर्व० ७/१८१ की आठ. टीका)

बाँध कर^१ या बँधे होने सदृश अनुभूति के साथ ऊर्ध्व खवास^२ अथवा उच्छ्वास करके^३ हृदय की ऊर्ध्व गति कर^४ अथवा उसका अवरोध कर^५ गर्भिणी को भी शीघ्र ही मार देती है। इस अत्यन्त कठिन व्याधि का नाम योनिसंवर्ण है जो यमराज सदृश घातक है अतः इसकी चिकित्सा नहीं प्रारम्भ करनी चाहिए^{६,७}।

इस व्याधि में वायु अर्थात् नाड़ियों के कार्य में विकार होने के कारण योनि (वैजाइनें) तथा गर्भाशयद्वारा (सैक्सिक्स) का संकोच मुखलया होता है अर्थात् इसे सैक्सिकैल डिस्टेंसिये समझ सकते हैं जिस व्याधि में उदर-विषाटन द्वारा प्रसव कराना पड़ता है।

४) योनिभ्रंश—योनिभ्रंश से गर्भाशयभ्रंश का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। गर्भाशयभ्रंश के साथ अवरुद्ध प्रसव कष्ट-चिकित्स्य होता है।

५) गर्भ की मकुष्ठ या मथुर गति या गर्भाशय-पेशी की कार्य विहीनता—गर्भाशय-पेशियों की अत्यधिक क्रिया-विहीनता की स्थिति में गर्भ की प्रसव के लिए गति मथुर हो सकती है यद्यपि सामान्यतया गर्भाशय-पेशियों की औषधियों द्वारा उत्तेजित कर उनकी संकुचन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है परन्तु कभी-कभी गर्भाशयिक मांसपेशियों में कार्योत्तेजक औषधियों का प्रभाव नहीं होता एवं उदर-विषाटन द्वारा ही गर्भ का आहरण करना पड़ता है अर्थात् गर्भाशयिक क्रिया-विहीनता भी मूढगर्भ में असाध्यता उत्पन्न कर सकती है।

६) योनिसङ्घ—यदि योनि से स्त्री का प्रजनन-पथ ग्रहण करें एवं इसमें गर्भ का सङ्घ अर्थात् 'अत्यधिक संकुचित श्रोणिगुहा के कारण गर्भ का सङ्घ' अर्थ करें तो यह स्थिति भी मूढगर्भ में असाध्यता की द्योतक है क्योंकि शत्राग्रहण के अतिरिक्त प्रसव सम्भव नहीं होगा।

आ) सार्वदैहिक विकार

संहिताओं में वर्णित सार्वदैहिक विकार यथा इन्द्रियों द्वारा विपरीत ज्ञान (अत्यधिक कष्ट या अर्निद्रा अथवा विषमयता के कारण उत्पन्न), अभ्येय (कष्ट अथवा गर्भजन्य विषमयता के कारण), खवास, भ्रम (दैर्घ्यत्व जन्म या रक्तचाप-वृद्धि-जन्म), पूति-उद्गार (पोषणभाव के कारण कीटान बाँझ के निःसारण से), शीताङ्गता (अत्यधिक श्वसन या रक्तवह संस्थान के कार्य की अक्षमता जन्म), लज्जा-विहितता (संज्ञा-विकार के कारण) तथा नीलोद्भूत शिराये (उदर की पेशियों के अत्यधिक कार्य करने से उत्पन्न) आदि सभी लक्षण स्त्री की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के अत्यधिक ह्रास के परिचायक हैं जिनकी उपस्थिति में अवरुद्ध प्रसव असाध्य हो सकता है।

All these signs/symptoms of incurability of *mūḍhagarbha* can be grouped under two headings i. e. abnormalities of passage and general systemic disorders. Though 7th and 8th *gaṭies* have also been said to be incurable, however, in the description of management

१. वातलान्घनपानानि प्राप्यधर्मं प्रजागरम् । अत्यर्थं सेवनानया गर्भिण्या योनिगर्भगः ॥

मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारास्य संवर्णितः । कुपले रुद्धमार्गत्वात् पुरात्कर्तव्योऽनिलः ॥

निरुण्णद्वाराशयद्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितम् । निरुद्धजनोच्छ्वासो गर्भश्चासु विपद्यते ॥

वृद्धां संरुद्धद्वारं नाशयत्सासु गर्भिणीम् । योनिसंवरणं विहाय व्याधिर्मेने सुरक्षयम् ॥

अनकप्रतिमं धोरे नारयेत चिकित्सयम् ॥ (पा० नि० ६४/१० की मधु० व्याख्या)

२. वातलान्घनपानानि योनिगर्भगः । मातरिश्वा अनिलः ॥

निरुण्णद्वारं निरुद्धजनोच्छ्वासो गर्भश्चासु विपद्यते ।

उच्छ्वास उद्बर्हद्वाराशयद्वारं गर्भिणीम् । योनिसंवरणं नाम व्याधिर्मेने प्रवक्षते ॥ अनकप्रतिमं ॥

(पा० प्र० वि० ७७/१९ की टीका शेष नं० १ सदृश ही वर्णन)

३. यो० ७० स्त्रीयो० नि० (पा० प्र० सदृश ही केवल उच्छ्वास ऊर्ध्वहृदयों के स्थान में उच्छ्वासरुद्धद्वारों)

surgical treatment for these both has been advised. This indicates that here the incurability refers to the impossibility of delivery by use of drugs, hymens or manual extraction. Surgical procedures were never free from risk, thus these both the *gaṭies* have been enlisted as incurable. The clarification of abnormalities of passage and general disorders is being given here.

A) Abnormalities of passage

i) *Garbhakosa-parāsaṅga* — *Dalhana* has offered two explanations to this word i. e. over clinging of fetus in the uterus or attachment of fetus in other than its normal place. Over clinging does not seem to be proper explanation as word '*para*' denotes away not excessive or over. For attachment or stay of fetus at other place than the uterus the rupture of uterus is essential. Sir M. M. William has explained the word '*parāsaṅga*' as 'cleaving' which means split (often asunder, in two) and break also. Rupture of uterus sometimes is seen in cases of obstructed labour and is considered to be one of the serious complication even today. Considering all this, here *garbhakosaparāsaṅga* should be considered as rupture of uterus.

Āpanatā of *garbhakosa* or diseased state of uterus can be either due to rupture of uterus occurring at the time of delivery or congenital anomalies such as uterus arcuatus, didelphys, septate etc. or else due to fibroid uterus, which produce obstruction in the labour. In all these conditions the delivery can be effected only with cesarean section.

ii) *Makkalla*—*Dalhana* while commenting on verse of *sūtrasthāna* has referred it as accumulation of blood in uterus during labour before delivery of the child or intrapartum haemorrhage, however, in *nidānasthāna* he explains it as the pain arising after delivery due to blood getting obstructed by *vāyu*. This latter explanation does not seem to be proper as the question of delivery in a case of obstructed labour does not arise. *Ādhanalla* has very clearly classified *makkalla* in two i. e. developing during pregnancy and during puerperium. The fetus afflicted with physical and psychological diseases produces pain in abdomen, which is known as *garbhamakkalla*. *Makkalla* is characterized with spasmodic contraction of uterus, thus in reference to obstructed labour it denotes either intrapartum haemorrhage associated with severe pain or tetanic or spasmodic irregular uterine contractions. Intrapartum haemorrhage and tetanic or irregular uterine contractions are one of the important cause of difficulties in management of obstructed labour.

iii) *Yonisamvṛti* or *yonisamvāraṇa*—Though *Suśruta* and *Vāgbhata* have referred this word, yet have not detailed the disease. One finds the description of disease in *Madhukosa commentary*, *Bhāvaprakāśa* and *Yogarūpnākara* in following words—

Due to use of dietetics capable of vitiating *vāta*, excessive coitus and night awakening the *vāyu* situated in *yonimārga* (vaginal canal) of pregnant woman getting aggravated contracts the vaginal orifice. This very *vāyu* after obstructing the vaginal orifice moving inwards obstructing the aperture of *āśāya* (cervix of uterus) troubles the fetus situated inside the uterus. Fetus dies due to obstruction of its mouth and respiration. This inward moved

aggravated *vāyu* causes feeling of ligature or tightness in the cardiac region, shallow expiration (breathing) along with and upward movement (displacement of apex beat due to over distension of abdomen) along with obstruction to the heart of pregnant woman and then kills her. This dreaded disease is known as *yonisavarana* which is always fatal.

In this condition due to abnormality of *vāyu* or nervous functions the spasm of *yoni* (vaginal orifice) and *garbhāśāyāwāra* or cervix of uterus occurs or in other words this refers to severe degree of cervical dystocia in which condition cesarean section is needed.

iv) *Yonibhrāṇśa*—Here with *yoniibhrāṇśa* the uterine prolapse should be considered. In cases of prolapse the labour is often obstructed and very difficult.

v) *Slow progress of fetus or uterine inertia*—Due to uterine inertia the progress of labour becomes very slow. Though usually myometrium responds to uterine stimulants, yet, in few cases it becomes totally inert and does not respond to stimulants, thus, the fetus has to be extracted by cesarean section or in other words uterine inertia also causes incurability of *mūḍhagarbha*.

vi) *Yonisānga*—*Yonisānga* refers to the obstruction of fetus in the maternal passage probably due to contraction of pelvis. In contracted pelvis also the *mūḍhagarbha* becomes incurable as the delivery had to be completed by cesarean section.

B) General disorders

General disorders such as opposite or abnormal perception by cognitive organs and convulsions or tremors (due to excessive trouble, insomnia or toxæmia), dyspnoea, giddiness, foul smelling expiration (smell of ketone bodies due to marked catabolism in absence of nourishment), coldness of body (due to improper functioning of circulatory system), absence of shyness and appearance of blue vessels over the abdomen are indicative of loss of physical and psychological power, in which conditions obstructed labour becomes incurable.

मूढगर्भ की चिकित्सा (Treatment of mūḍhagarbha)

१) मूढगर्भ की चिकित्सिका/चिकित्सक के गुण (The qualifications of accoucheur or accoucheuse handling mūḍhagarbha)

महर्षि चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट ने प्रसव करने के लिए बहुतप्रसूता आदि स्त्रियों को विशेषतायें लिखी हैं जो पूर्ववर्णिता हैं। टीकाकार इन्दु ने अनेक प्रसव कराने से अनुभूत स्त्री को मूढगर्भ के प्रसव करने का निर्देश दिया है। अन्यत्र महर्षि सुश्रुत एवं अष्टाङ्गहृदयकार ने अन्तर्ममति अर्थात् विद्वान् वैद्य को ही इस अवस्था में चिकित्सा करने का निर्देश दिया है। महर्षि चरक एवं अष्टाङ्गसंग्रहकार ने दृढकर्मा शल्यहर्ता द्वारा शल्योद्धारण करने का निर्देश दिया है। भावप्रकाश तथा

१. अ० सं० शा० ४/३३ की इन्दु टीका (जीवित मूढगर्भ की प्रसव-विधि में वर्णित)
२. सु० सं० चि० १५/१४ व अ० शा० २/३६ (शस्त्रकर्मान्तर्गत वर्णित)
३. अ) परिदृढकर्मणा शल्यहर्ता हरणमित्येके । (च० सं० शा० ८/३१)
- आ) अ० सं० शा० ४/३५ (मूढगर्भ के सामान्य चिकित्सा सिद्धान्त में वर्णित)

योगरत्नाकर में मूढगर्भ की शस्त्र-क्रिया करने योग्य स्त्री की विशेषताओं को वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस स्त्री-वैद्य ने संकट काल में भी बहुत सी स्त्रियों का प्रसव कराया हो, जिसे (इस कार्य में) अच्छी प्रकार से यश प्राप्त हो, उसे इस क्रिया (मूढगर्भ के प्रसव-कर्म) को करना चाहिए। वह स्त्री वैद्य शस्त्र एवं शस्त्र को जानने वाली, विद्वान्, हलके हाथों से काम करने वाली तथा निर्भय होनी चाहिए।

Caraka has prescribed the only qualification that the accoucheuse must be multiparous, however, any qualification for the woman handling *mūḍhagarbha* has not been mentioned. Indu says that the woman having experience of conducting several labours should handle the case of obstructed labour. Suśruta and Vāgbhata II have opined that only wise physician should handle such case, while Caraka and Vāgbhata I say that the surgeon having seen the practical work of extracting the fetus in obstructed labour should handle such case. It appears that during the period of these writers the obstructed labour was handled by general surgeons. Bhāvaprakāśa and Yūgaratnākara giving detailed qualifications say that the accoucheuse having experience of conducting several difficult labours, thus being famous for this procedure and having command over the knowledge of instruments and books should handle the case of *mūḍhagarbha*, besides she should be wise, bold and capable of working with light/gentle hand.

२) मूढगर्भ के सामान्य चिकित्सा-सिद्धान्त (General principles of treatment of mūḍhagarbha)

मूढगर्भस्य तु जरायुपातनसामान्यं कर्तव्येके । मन्त्रादिकमथवेदविहितमित्येके । दृढकर्मणा शल्यहर्ता शल्यारोपमित्येके ॥ (अ० सं० शा० ४/३५)

मूढगर्भ में जरायु-पातन के लिए वर्णित सामान्य कर्म करना चाहिए ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं; अन्य आचार्यों का मत है कि अथर्ववेद में वर्णित मन्त्र आदि कर्म करना चाहिए; अन्य आचार्यों का मत है कि प्रत्यक्ष कर्म देखे हुए शल्य विशेषज्ञों द्वारा शल्य का आहरण करवाना चाहिए।

अन्यत्र महर्षि वाग्भट ने आहरण-योग्य शल्यों के उदाहरण में गर्भ-शल्य को ही कहा है, चरक का भी यही मत है (पृष्ठ ४७७)।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि श्रेष्ठ वैद्य। अंब में मूढगर्भ की चिकित्सा वर्णित करेगा। यदि निराहार होने के कारण गर्भाशय में गर्भ की मृत्यु हो जाय तो स्त्री का मर्दन या अभ्यङ्ग करके गर्भ को प्रयत्न पूर्वक निकालना चाहिए। महर्षि चरक द्वारा गर्भाशयान्तर मूढगर्भ के अन्तर्गत वर्णित चिकित्सा की विधि (पृष्ठ ४७७) का प्रयोग करना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत ने मूढगर्भ को बलित-साध्य एवं आहरण-योग्य व्याधि वर्णित किया है। सभी आचार्यों ने अपप्रसूता

१. अं) यतिः सङ्कटकालेऽपि बह्व्यो नायः प्रसाधितः । सम्यक्त्वान्बं यशस्तस्वु नायः कुर्तुमां क्रियाम् ॥ १२० ॥
शस्त्रशस्त्राधीविदुषो लघुहस्ता भयोद्धिता ॥ १२१ ॥ (भा० प्र० चि० ७०/१२० तथा १२२)
आ) यतिः सङ्कटकाले वैद्योनायः प्रसाधितः सम्यक् । त्वन्बं यशः समग्रस्ता एवातः क्रियाः कुर्तुः ॥
शस्त्रशस्त्राधीविदुषो लघुहस्ता भयोद्धिता ॥ (च० सं० शा० २/३३)
२. गर्भशल्यमाहार्यमाणम् । (अ० सं० सू० १३/३)
३. मूढगर्भस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वर ।
मर्दयित्वा मानुषीञ्च तल्लङ्घयि प्रयत्नतः । निराहाराच्च श्रित्यते यदि गर्भोऽन्तरे स्थितः ॥ (हा० सं० तु० स्या० ५२/१५, १६)
४.मूढगर्भप्रभृतिषु चालस्यमुपयुज्यते । (सु० सं० चि० ३५/५)
५. आहार्याःमूढगर्भाश्च ॥ (सु० सं० सू० २५/११, १२)

अ) आसुरी, हिंगु एवं सैन्धव नामक को काञ्ची में घोलकर पिलाने से गर्भाशय में मग्न हुआ गर्भ शीघ्र ही बाहर आ जाता है^१ ।

आ) बोट्टी के मल को काँजी में घोलकर वस्त्र से छानकर उसमें सैन्धव, उष्ण, आसुरी तथा तैल (तिल तैल) मिलाकर पान करने से विषम रूप से आए हुए (मृद) गर्भ का प्रसव हो जाता है^१ ।

इ) परशक-शिफा अथवा शिफा को मूल (के कल्क) का नाभि, बलित तथा भग आदि अङ्गों में लेपन मूढगर्भ का अयकर्षण करने वाला होता है^१ ।

मदभिं काश्यप ने वरपक्व के अन्तर्गत वर्णित मातङ्गीविद्या को कृच्छ्रप्रसवा को सुनाने से शीघ्र प्रसव होने का उल्लेख किया है^१ ।

Till the fetus is alive every effort should be made to deliver it. If delivery does not take place then this *cyawanamantra* i.e. "O Woman ! in your this temple *amrita*, *soma*, *citrabhanu* and horse named *uccaiṣṭravā* should live..... O Fetus ! do not delay come out, come out, what-so-ever is said is correct" (see under normal labour page 452 and 454, 455) should be used. The medicines prescribed for expelling the retained placenta should also be used.

Vāgbhata II has added that besides above treatment the *yoni* (external genitalia and vaginal canal) should be irrigated with lukewarm water followed by anointing it with jaggery, *kirva* (seeds or drugs used for fermentation) and salt. The vagina should be repeatedly filled with these jaggery etc. or with gum of *śalmāl* mixed with mucinous substance obtained from *ausi*.

Hārīta has prescribed following drugs for quick and easy delivery—

- a) Root of *lāṅgāl* pestled with hot water should be applied over umbilicus.
- b) Root of *balā*, *sūryakāni* and *somavāl* pestled with *kāñjī* should be applied.
- c) Roots of *bhīru*, *bhūminba*, *vārāki* and *pīpālīyaka*, *yawān*, *agra* and *vacā* pestled with warm water should be applied below the umbilicus.
- d) Roots of *lāṅgāl* and *devadāl*, *tumbicā* and *kośāki* pestled together should be applied.

e) Following *mantras* should be recited for easy delivery.

- i) "In northern bank of *himālaya* there lives a *rākṣasī* named *Surasā*, by hearing the sound of her *nūpura* (an ornament) the woman delivers easily".
- ii) Use of water or milk treated with "*Aṅ hrī cālaya cālaya swāha*" etc. *mantra* facilitates delivery.
- iii) "*Aṅ hrīṃ...hrāḥ*" etc. hymn should be written on upper portion of *bhūjapātra*, this should either be shown to the woman or kept under her bed.

१. आयुर्विहङ्गिसमूह काञ्चिकेनाल्लोडितम् । गर्भाशये मृतं गर्भं पातयेत्तानयोगतः ॥

अलोड्य काञ्चिकेर्वाटोपुरीषं वस्त्रमाहितम् । ससिन्धुयासुरी तैलं विषमागतामर्पयत् ॥

परुषकशिफालेपः शिफामूलकनोऽथ वा । नाभिर्वस्तिष्माग्रेषु मूढगर्भायकर्मणः ॥ (यो० २० स्त्रीरोग चि०)

२. का० सं० कल्प० ६/८० (पृष्ठ ३५६ से ३५९)

iv) "There lives a she-crow at the bank of *ganges*, the water dropped from her feathers given immediately to the woman brings her delivery, this is the saying of *kākarāṇḍra*" reciting this hymn repeatedly when the physician gets tired, then this treated water should be given to the woman for drinking. By use of this the woman delivers in the same way as she-crow lays the eggs without pain or difficulty.

Yogaratanākara has prescribed following drugs—

i) By using *āsuri*, *hingū* and rock salt churned with *kāñjī* the dead fetus gets expelled immediately.

ii) The feces of mare should be dissolved in *kāñjī* and strained through a cloth. In this filtrate rock salt, *ugrā*, *āsuri* and *tila* oil should be mixed. Oral use of this helps in delivery of abnormally presenting obstructed fetus.

iii) Anointment of pestled root of *parīśaka* or *sihīrā* over umbilicus, urinary bladder region and vulva expels the obstructed fetus.

In the benefits of *māraṅgvidyā* referred under *varanabandha* Kāśyapa says that the woman having difficult labour, if listens to this, delivers easily.

४) दौषिक मूढगर्भ की चिकित्सा (*Treatment of mūḍhagarbha due to different doṣas*)

अ) वातिक मूढगर्भ की चिकित्सा (*Treatment of mūḍha garbha due to vāta*)

वातिक मूढगर्भ में मर्दन, अथ्वाङ्ग, अल्प स्वेदन तथा पञ्चकोल की यवागू का पान कराने^१ ।

Rubbing, massage, slight sudation and gruel of *pañcakola* should be prescribed.

आ) पित्तिक मूढगर्भ की चिकित्सा (*Treatment of mūḍhagarbha due to pitta*)

पित्तज मूढगर्भ में शीतल के साथ शीतल जल का पान तथा विभिन्न (शाक आदि) व्यञ्जन एवं यष्टिक को दूध के साथ पीने को दे^१ ।

Cooled water after consuming cooled diet, *śāka*, other cold edibles and *yastika* with milk should be given.

इ) रक्तौषिक मूढगर्भ की चिकित्सा (*Treatment of mūḍhagarbha due to ślegmā*)

रक्तौषिक मूढगर्भ में त्रिकटु, त्रिफला, कुष्ठ, रोष, वत्सक तथा धातकी (पुष्प) को गुड़ के साथ क्वाथ बनाकर पीने को दे^१ ।

Decoction of *trikatu*, *triphalā*, *kusṣha*, *rodhra*, *vatsaka*, flowers of *dhātākī* along with jaggery should be given.

ई) मूढगर्भ में रक्त एवं पित्तज विकार होने पर चिकित्सा (*Treatment of rakta and pitta disorders in mūḍhagarbha*)

रक्त एवं पित्त के विकार में मूर्वा, चिञ्चला, वास्तुकर्ण, मञ्जिष्ठ, रोष, नीलिका, कर्कशु-मूल तथा सौराष्ट्री का गुड़ के साथ क्वाथ बना कर दे इससे कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है^१ ।

१. वातिके मर्दनाथङ्गं स्वेदनं वाल्मेयव च । यवागू पञ्चकोलश्च पायवेन्द्रियगुप्तः ॥ (हो० सं० तु० स्या० ५२/११)

२. धैतिके शीतलं पानं शीतलजलं हिमं च । व्यञ्जनाणि तथा तस्य यष्टिकं पयसा पिबेत् ॥ (हो० सं० तु० स्या० ५२/१२)

३. त्रिकटु त्रिफला कुष्ठं रोषं वत्सकयष्टुकी । सगुडं क्वाथितं पाने रलेष्मणो मूढगर्भके ॥ (हो० सं० तु० स्या० ५२/१३)

४. मूर्वाचिञ्चलावास्तुकर्णमञ्जिष्ठारोषनीलिकाः । कर्कशुमूलं सौराष्ट्री क्वाथश्च सगुडो हितः ।

रक्तपित्तविकारेषु कुक्षिशुद्धिश्च जायते ॥ (हो० सं० तु० स्या० ५२/१४ व १५)

Decoction of *mūrvā, ciñcā, vāstukarṇā, rodhira, mīlikā, root of kartandhu, saurāsīn* and *jaggery* should be given, this cleanses the *koṣṭhā*.

५) मृत मूढगर्भ की चिकित्सा में विलम्ब या उपेक्षा का परिणाम (Effect of negligence or delay in the treatment of dead *mūḍhagarbha*)

नोपेक्षित मृतं गर्भं मुहूर्तमपि पण्डितः । स ह्यशु जननीं हन्ति निरुच्छ्वासं पशुं यथा ॥
(सु० सं० चि० १५/१५)

न तु क्षणमप्युपेक्षेत गर्भशल्पम् । तद्धि निरुच्छ्वासीकृत्याशु जननीं हन्यात् ॥
(अ० सं० शा० ४/३२)

न चोपेक्षः क्षणमप्यस्तजीवितः ॥ (अ० ह० शा० २/३७)

पण्डित या विद्वान् वैद्य को मृतगर्भ की क्षण भर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अर्थात् तत्काल ही चिकित्सा प्रारम्भ कर देनी चाहिए, क्योंकि वह (मृतगर्भ) शीघ्र ही माता को रक्तासावरोध से मारते हुए पशु की तरह मार देता है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि गर्भशल्प की क्षण भर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह रक्तासावरोध करके माता को शीघ्र ही मार देता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार का भी यही मत है कि मृतगर्भ की क्षण भर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे जीवन का अस्त हो सकता है ।

महर्षि हारीत ने "आयुर्कातो व्याधि" अर्थात् शीघ्र ही चिकित्सा करने की व्याधि कहकर वर्णन किया है ।
भावप्रकाश तथा योगरत्नाकरकार ने लिखा है कि मृतगर्भ की क्षण भर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह स्त्री को उसी प्रकार मार देता है जिस प्रकार अत्यधिक अन्न खा लेने से पशु (उदर में आप्थान हो रक्तासावरोध होने से मृत्यु सम्भव है) ।

The wise physician should not neglect the dead *mūḍhagarbha* even for a moment and start the treatment immediately, because this dead fetus kills the mother by distension of asphyxia in the same way as an animal dies due to asphyxia caused by distension of abdomen due to over-eating.

६) गर्भ-शल्योद्धरण की कठिनाइयाँ (Difficulties during extraction of *garbha-salya*)

नातोऽन्यत् कष्टतममस्ति यथा मूढगर्भशल्योद्धरणम्; अत्र हि योनियकृत्सीहीहान्नविचाराभ्यासानां मध्ये कर्म कर्तव्यं स्मर्यते । उत्कर्षणपर्यवसानपवर्तनोद्धर्तनोद्धर्तनभेदनच्छेदनपीडननर्तकपादराणानि चैकहस्तेन गर्भं गर्भिणीं चाह्वेयता ॥ (सु० सं० चि० १५/३)

नन्ततः कष्टतममस्ति शस्त्रकर्म । यतो योनियकृत्सीहीहान्नविचाराभ्यासादीनां मध्ये ताननुपहिसताऽस्पर्शवता शस्त्रमवधार्यनुत्कर्षणव्यवर्तनोद्धर्तनभेदनपीडननर्तकपादराणि चैकैकं पाणिना कार्याणि ॥

(अ० सं० शा० ४/३६)

मूढगर्भ-शल्योद्धरण के समान कोई अन्य शल्योद्धरण कष्टकारी नहीं है । इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, आन्त्रविवर

१. मृतगर्भ विजानीयादशुकाती रिक्त्यामीपि । (ह० सं० स्या० ५/२/१०)
२. अ) नोपेक्षित मृतं गर्भं मुहूर्तमपि पण्डितः । तदशु जननीं हन्ति प्रभूतान् यथा पशुम् ॥ (पा० प्र० चि० ७०/१२४)
आ) नोपेक्षते..... । स चाऽऽशु जननीं..... । (पा० प्र० सदृश ही) (यो० २० स्त्रीरोगे चि०)

(ओंतों का स्थान या उदर) तथा गर्भाशय आदि के मध्य में स्पर्श के द्वारा (अर्थात् बिना प्रत्यक्ष देखे) ही कर्म (शल्योद्धरण-कर्म) करना होता है । उत्कर्षण (अत्यधिक नीचे आये हुए को ऊपर खींचना), अपकर्षण (ऊपर चले गये हुए को नीचे खींचना), स्थानापवर्तन (गर्भाशय में आसक्त उत्तान गर्भ को अवाङ्गमुख करना), उद्धर्तन (अवाङ्गमुख को उत्तान करना), उत्कर्तन (किसी ऊर्ध्व स्थित अङ्ग का कर्तन), भेदन (आपथान युक्त गर्भ की कुक्षि का विदारण), छेदन (मृतगर्भ के गर्भाशय में सक्त अङ्गों का छेदन या फाटकर दो में बाँटना), पीडन (बलन या दबाना), ऋजुकरण (टूटे अङ्गों का सीधा करना) तथा दारण आदि कर्म गर्भ (यदि जीवित है) एवं गर्भिणी को बिना हिंसा किए या आपात पहुँचाये एक ही हाथ से करने होते हैं । टीकाकार डल्हण ने पाठभेद का वर्णन करते हुए स्थानापवर्तन के स्थान में स्थानव्यवर्तन अर्थात् गर्भाशय में तिथ्यागदि स्थिति में स्थित उत्तान गर्भ को अपोव्यवर्तन कर अर्थात् नीचे की ओर लाकर स्थापित करना लिखा है ।

महर्षि वाग्भट ने भी यही लिखा है कि यह कष्टतम शस्त्रकर्म है इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, आन्त्र, गर्भाशय आदि के मध्य में इनको हानि पहुँचाये बिना तथा इनको स्पर्श न करते हुए (शल्योद्धरण के समय केवल गर्भ को ही स्पर्श करते हुए) शस्त्र का प्रेक्ष करके उत्कर्षण, अपकर्षण, व्यवर्तन, उत्कर्तन, छेदन, भेदन, पीडन तथा ऋजुकरण आदि कर्म एक हाथ से ही करने पड़ते हैं । पाठभेद में अस्पर्शवता पाठ मिलता है जिसके स्मरीकरण में टीकाकार इन्द्र ने लिखा है कि योनि आदि की रक्षा करते हुए स्पर्श के द्वारा ही ज्ञान करके बिना देखे ही शस्त्र का अवधारण करना होता है जो वर्णन महर्षि सुश्रुत सदृश ही है ।

The extractions of fetus is most difficult in comparison to any other *salya* (foreign body). In this, every manipulation or action has to be done only on the basis of palpation without visualizing any thing, and amongst the *yoni*, liver, spleen, bowels and uterus. *Utkarṣana* (pulling the fetus upwards which has come too much down), *apkarṣana* (dragging the fetus downwards which has moved much upwards), *śhāntāpavartana* (rotation or cephalic version), *udvartana* (pushing the face upwards) *utkarṣana* (cutting), *bhedana* (perforation), *chedana* (excision), *pīḍana* (compression or pressure application) *ṛjūkarana* (straightening) and *dāraṇa* (incision) etc. all the acts had to be done only with one hand taking care not to injure the mother and fetus (if alive) both.

७) शस्त्र-कर्म के पूर्व भोजन-निषेध (Contraindication of ingestion of food before surgical procedure)

महर्षि सुश्रुत ने शस्त्र-कर्मों के लिये सामान्य निर्देश देते हुए मूढगर्भ, उदर, अर्श, असमरी, भान्तर, मुखरोग आदि व्याधियों में बिना खाना दिए या खाली पेट ही शस्त्र-कर्म करने का निर्देश किया है । कारण का स्मरीकरण करते हुए टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि इन पाँचों व्याधियों में अन्न से कोष्ठ के पूर्ण होने पर शस्त्र के प्रवेश में कठिनाई अथवा आगुर की मृत्यु तक हो सकती है तथा वायु का भी प्रकोप होता है ।

१. उत्कर्षणमधोरात्र्योर्ध्वाकर्षणम्, अपकर्षणमूर्ध्वरात्र्योर्ध्वाकर्षणम्, स्थानापवर्तनं स्थानेषु सकस्य गर्भाशयात् उत्तानस्या वाङ्मुखीकरणम्, उद्धर्तनमवाङ्मुखस्योत्तानीकरणम्, अत्र केचित् स्थानव्यवर्तनमिति पठन्ति, तत्र स्थानं स्थितिः स्थाने गर्भाशयात् तिथ्यागदिस्थितस्थानस्याधोव्यावृत्त्या स्थानम्, उर्ध्वस्य कस्मिन्दङ्गस्य छेदनमुत्कर्तनं, छेदनमिति मृतस्य तु तेषु तेषु स्थानेषु सकस्य तस्याङ्गस्य छेदनं द्वैधकीकरणम्, गर्भकुक्ष्यादोपपान्तस्य विदारणम् भेदनम् । पीडनम् बलनम् ऋजुकरणं वक्रस्य प्राञ्चलीकरणम् । दारणं विदारणम् । (सु० सं० चि० १५/३ को डल्हण टीका)
२. ताननुपहिसतास्पर्शवता (पाठभेद) ।
यतो योन्यादीनि रस्याणि स्पर्शनिषेधे शस्त्रमवधार्यमर्दुणिगोचरान्त्व । (अ० सं० शा० ४/३६ को इन्द्र टीका की पुस्तक में पाठभेद तथा इन्द्र टीका) ।

३. मूढगर्भादृशोऽसमरीभान्तरमुखरोगोष्णभुक्तवतः कर्म कुर्वते ॥ १६॥
(मूढगर्भादिषु षट्स्वस्त्रपूर्वकोष्ठत्वाद यन्नदानादिभिः कष्टं मरणं वा प्राप्नोत्यागुरः, अतिलक्ष प्रकोपमेति-डल्हण)
(सु० सं० सू० ५/१६)

वापट-द्वय ने भी मूढगर्भ की शस्त्र-चिकित्सा के पूर्व भोजन निषिद्ध किया है। टीकाकार इन्दु ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र-कर्म करने से पहिले भोजन नहीं देना चाहिए, टीकाकार अरुणदत्त का मत है कि भोजन का निषेध है परन्तु मद्यपन करना चाहिए; टीकाकार हेमद्वि ने भोजन तथा मद्यपन दोनों का ही निषेध किया है।

In five disorders i.e. *mūḍhagarbha*, *arśa* (piles), *asṃarī* (urinary bladder stones), *bhagavadara* (rectal/anal fistula) and *mukharoga* (diseases of mouth) the surgery should be done in empty stomach, because in full abdomen there may be difficulty in insertion of instruments or the patient may die and *vata* also gets aggravated.

Ingestion of food is contraindicated before surgical treatment of *mūḍhagarbha*. Arunadatta says that though the food is contraindicated, yet the wine should be prescribed, however Hemadri also has contraindicated both.

८) गर्भ-शल्योद्धारण के पूर्व अधिपति की आज्ञा (*Consent of guardian before surgical intervention*)

तस्मादधिपतिमापृच्छ्य परञ्च यत्नमास्थायोपक्रमेत । (सु० सं० चि० १५/३)

तस्मादीश्वरमापृच्छ्य परं च यत्नमास्थाय तद्विषयसहितस्तमुपक्रमेत । अक्रियायां ध्रुवं मरणम् उपक्रमे संशयः ॥ (अ० सं० शा० ४/३७)

अथापृच्छ्येशं वैद्यो येत्नेनाश्रुतमाहेत् । (अ० ह० शा० २/२६)

उत्तमं (गर्भ-शल्योद्धारण में) अधिपति से पूछकर, यत्नपूर्वक स्थापित करके (स्त्री को उचित स्थिति में सुलाकर) उपक्रम करना चाहिए ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी यही लिखा है कि नसमें ईश्वर (स्वामी या मालिक) से पूछकर यत्नपूर्वक स्थित करके उसकी (मूढगर्भ-शल्योद्धारण को) विद्या-सहित (पूर्वकर्मप्राप्त से प्राप्त ज्ञान के आधार पर) उपक्रम करे क्योंकि अक्रिया या शल्योद्धारण न करने से मृत्यु (स्त्री को) निश्चित है तथा उपक्रम करने में संशय या सफलता की प्राप्ति में संदेह है। टीकाकार इन्दु का मत है कि ईश्वर से पूछकर कर्म करने में स्त्री की मृत्यु हो जाने पर भी अपराध नहीं मिलता । अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि वैद्य ईश्वर (पुन-अरुणदत्त) से पूछकर यत्नपूर्वक शौचातिशय आहरण (गर्भ को) करे ।

Before extraction of *mūḍhagarbha* the consent of guardian must be obtained explaining that if the surgical interference is not done death (of mother) is sure and even in surgical procedure there is doubt in success. After this, placing her in proper position surgery should be done. Indu has explained that by obtaining consent the physician does not get defamed even if woman dies.

विमर्श (Comments)

आधुनिक काल में भी शल्य-कर्म से पूर्व चिकित्सा-विधि-द्वय आधिपति की आज्ञा अनिवार्य है। अपर्युक्त वर्णन

१. अ) अन्यत्र मूढगर्भोद्धारणमुद्धारीष्यः ॥ १४ ॥

(प्राक् शस्त्राच्छस्त्रकर्मणः पूर्वं मूढगर्भादिषु भोजनस्य प्रतिषेधः-इन्दु) ॥ (अ० सं० सू० ३८)

अ) अन्यत्र मूढगर्भस्यमुद्धारीष्यः भोजनं मद्यपनं च कारयितव्यम्-अरुण० ॥

(मूढगर्भादिषु आगुस्तं वर्जयितव्यं भोजनं मद्यपनं च कारयितव्यम्-अरुण०) ॥

(मूढगर्भादी भोजनमद्यपनं निषेधति-अन्यत्रोक्ति - हेमद्वि) (अ० ह० सू० २९)

२. तस्मादधिपतीश्वरमापृच्छ्य यथा मुलायमायशसा योगो न भवतीति । (अ० सं० शा० ४/३७ की इन्दु टीका)

उस काल के चिकित्सा-विधि-विज्ञान के विशिष्ट महत्व का द्योतक है ।

The consent of guardian before any surgical procedure is essential specially from medicolegal point even today. This shows the high standard of medical ethics existing at that time.

९) गर्भ-शल्योद्धारण के समय स्त्री की स्थिति एवं वैद्य द्वारा हस्त-प्रवेश-विधि (*The position of woman during extraction of mūḍhagarbha and method of insertion of hand by surgeon*)

मृते चोत्तानाया आश्रुनसकस्या वस्त्राभाकोशमितकट्या ध्वन्वनगवृत्तिकाशास्त्रालीमृत्तपृताभ्यां प्रक्षीयित्वा हस्तं योनौ प्रवेश्य गर्भमपहरेत् ॥ (सु० सं० चि० १५/९)

अथोत्तानाया व्याश्रुनसकस्यावस्त्राभालीमृत्तपृताभ्यां प्रक्षीयित्वा हस्तं योनौ च गर्भमपहरेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/३८)

हस्तमपश्यन् योनिं च साव्यशास्त्रमपिच्छ्या ॥ (अ० ह० शा० २/२७)

गर्भ के मृत हो जाने पर (अथवा औषधि या मंत्र चिकित्सा के विफल होने पर जीवित गर्भ में भी-पृष्ठ ४८०, ४८१) सक्थियों (जंघाओं) को मोड़ कर, उत्तान सोई हुई, कपड़ों की गद्दी से ऊँची की हुई काटि वाली स्त्री (चि० १७) की योनि में ध्वन्न (बदरी सदृश पत्र का धनुर्वक्ष), नावृत्तिका (सल्लकी), शास्त्राली, मिट्टी तथा घृत लगाकर (वैद्य) हाथ (चि० १८) का प्रवेश कर गर्भ का आहरण करे । मृत्तन का प्रयोग उचित नहीं है इसी दृष्टिकोण से टीकाकार इन्दु ने मृत्तन से पिच्छा या निर्यास लेने का निर्देश दिया है अर्थात् उपर्युक्त औषधियों के गोंद तथा घृत से हाथ को चिकना करके योनि में प्रवेश कर गर्भमपहरण करे ।

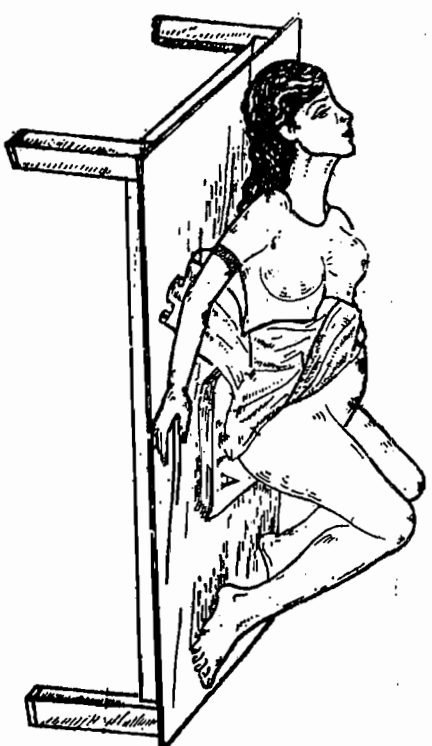


Fig. (17) : The position of woman for delivering obstructed fetus. Note supine position with flexed thighs. (A) hips are elevated with thick pad of cloths.

१. चकारादफलप्राप्तेषु.....(पृष्ठ ४८१).....। ध्वन्नो धनुर्वक्षो बदरीसदृशपत्रः। नावृत्तिका शक्की; यद्यपि मृत्तनशब्दः प्रसस्तायां मुदि वर्तते तथाऽप्यत्र धनुर्वक्षशक्कीशास्त्रालीनां पिच्छलेक्वेव मृत्तनशब्दो बोद्धव्यः ॥

(सु० सं० चि० १५/९ की इन्दु टीका)

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि सक्थियों को मोड़कर, उत्तान लेटी हुई स्त्री जिनकी कटि मुलायम कपड़ों की गद्दी से ऊँची कर दी गई है, की योनि का धन्व, नागवृत्तिका (नागवृत्तिका-पां भेः, शल्लकी-इन्दु^१) तथा शाल्मली की पिच्छा या गोंद तथा घी से अभ्यंग कर इन्हें द्रव्यों से अभ्यङ्ग किए हुए हाथ का प्रवेश करके गर्भ का आहरण करे। अष्टाङ्गहृदयकार ने संक्षेप में लिखा है कि हाथ तथा योनि को शाल्मलीनिर्यास से अभ्यङ्ग करके हाथ को योनि में प्रविष्ट करें।

महर्षि हारीत ने नाभि-बिल के समान गोल कुण्डलिका बनाकर उसके ऊपर जातु फैलाकर बैठी हुई स्त्री में मूढगर्भ निकालने का विधान दिया है^२।

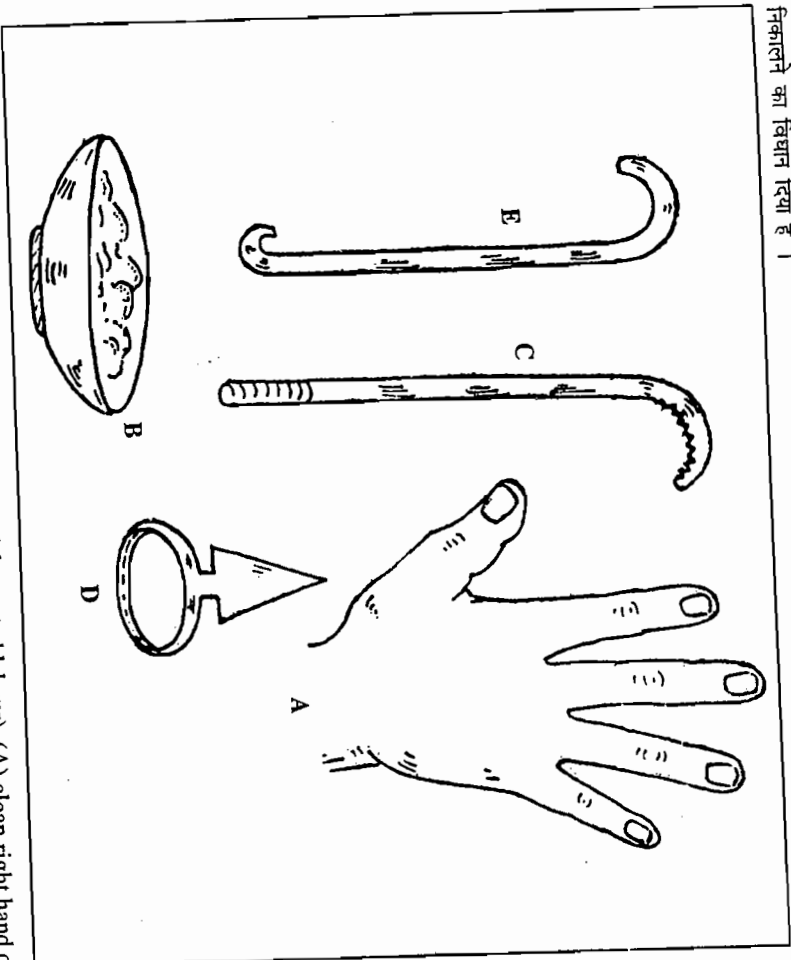


Fig (18) : Assets for delivering *mūḍhagarbha* (obstructed labour), (A) clean right hand of surgeon with nails trimmed (B) a bowl containing mucinous substance for lubricating hand and vagina; (C) *māṇḍalāgra śāstra* used for cutting the fetal parts; (D) *aṅgulī śāstra* used for perforating the fetal head, abdomen etc. and; (E), *śaṅkhā* or hook used for extracting the cut or perforated fetal parts.

१. धन्वानागवृत्तिकाशाल्मली.....(पाठभेद) (नागवृत्तिका शल्लकी-इन्दु)
(अ० सं० शां० ४/३८ की इन्दु टीका पुस्तक का पाठ भेद तथा इन्दु टीका)
२. (ह्रीं० सं० वृ० स्या० ५२/१७, हाथ से आहरण विधि में उद्धृत)।

भावप्रकाश तथा योगरत्नाकरकार ने लिखा है कि सर्पिषाक हस्त का योनि में प्रवेश करके जीवित गर्भ को यत्न से निकालना चाहिए^१।

Once the fetus is dead or medicinal treatment has failed, the extraction of fetus should be done by keeping the woman in supine position with flexed thighs, her hips should be elevated by keeping a thick pad of cloths (fig. 17). The vagina and hand (fig. 18) should be lubricated with mucinous substance or gum of *dhanwana*, *naḡavṛtikā* (*sallakī*), *śālmālī* and *ghṛta*. Now the fetus should be extracted by inserting the hand.

Both the *Vāgbhaṭas*, *Bhāvaprakāśa* and *Yogarātnākara* have expressed almost identical views, however, *Hārīta* says that the lady should be made to sit over a circular thick pad made for the purpose, with extended (abducted) thighs during extraction of *mūḍhagarbha*.

विमर्श (Comments)

कटिप्रदेश को ऊँचा करके सक्थियों को मोड़कर उत्तान लेटने पर स्त्री की स्थिति आधुनिक पुस्तकों में वर्णित लिथोटॉमि स्थिति के सदृश हो जायगी, जिस स्थिति में योनिमार्ग से गर्भ का आहरण अति सुगम होगा। महर्षि हारीत द्वारा वर्णित स्थिति कार्य की दृष्टि से सुगम नहीं है।

Supine position with flexed thighs and elevated hips resembles to a greater extent with lithotomy position used today for all vaginal operations or deliveries. Squatting position advised by *Hārīta* does not seem to be justified.

१०) मूढगर्भ को हाथ से आहरण करने की विधि (Procedure of manual extraction of fetus)

विभिन्न प्रकार से प्रसवित होने वाले गर्भों का निम्नाङ्कित विधि से आहरण करें।

(अ) दोनों सक्थियों (जंघाओं) से प्रसवित होते हुए गर्भ को नीचे की ओर से ही खींचकर निकालें^{१,२}। (चि० १९ अ एवं ब)।

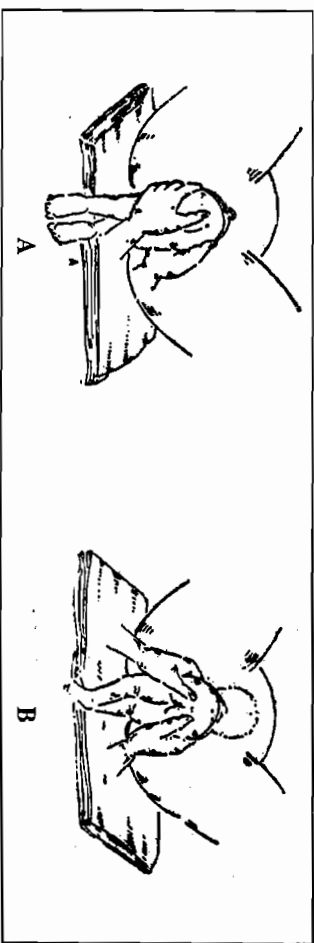


Fig (19) : Method of extraction of fetus delivering with both the thighs (footling presentation); (A) step I—Both the thighs are held and pressure for extraction applied; (B) step II—with further descend the shoulders are held and downwards traction is given.

१. गर्भ जीवित मूढ़े व गर्भ यत्नेन निश्चित। हस्तेन सर्पिषाकेन योनेस्तत्तान सा ॥
(भा० प्र० चि० ७०/१२१ तथा यो० १० स्त्रीरोग चि०-सर्पिषाऽके-पाठ)
- नोट- आहरण करने की विधि के सन्दर्भ पृष्ठ ५२२ में देखें।

आ) एक सक्थि से प्रसवित होने वाले गर्भ की पहिले दूसरी सक्थि को भी फैलाकर या निकाल कर (चि० २० अ) फिर आहरण करें^{१,२} (चि० २० ब)

इ) सिका-देश से प्रसवित होते हुए गर्भ के सिका प्रदेश को पीड़न करके (स्वस्थान स्थिति से विचलित करके)

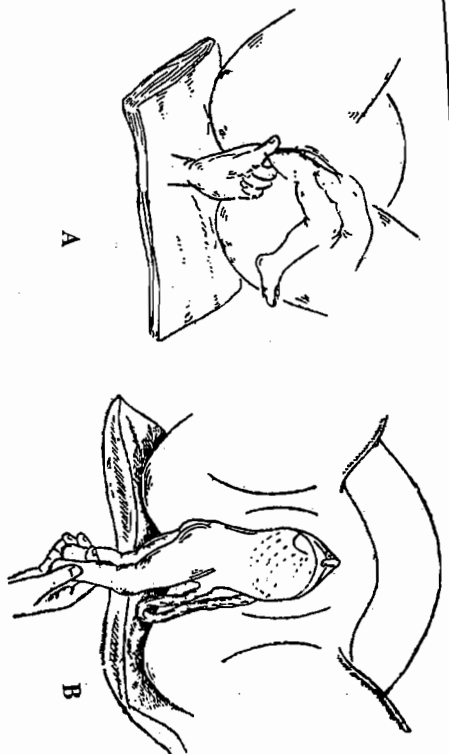


Fig (20) : Method of extraction of fetus delivering with one thigh (footling presentation) (A) Step I—second thigh is delivered; (B) step II—the fetus is delivered by downward traction.

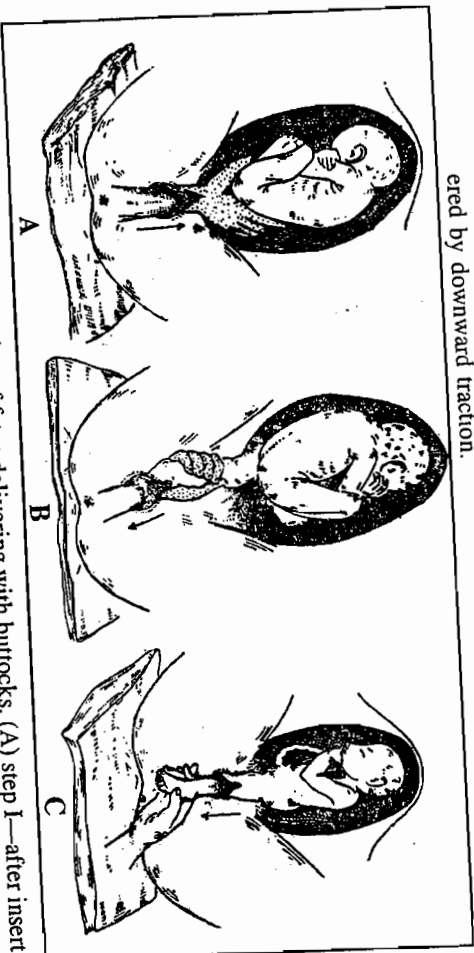


Fig (21) : Manual extraction of fetus delivering with buttocks. (A) step I—after inserting the hand in the uterus, the buttocks are dislodged and pushed up; (B) step II—the legs are grasped one by one; (C) step III—the fetus is delivered by downward traction.

नोट—सन्दर्भ पृष्ठ ५२२ में देखें।

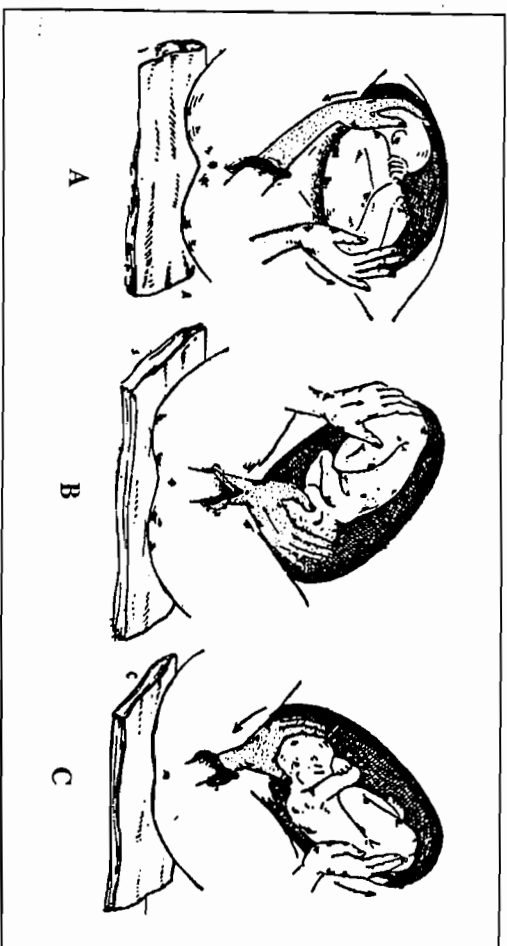


Fig (22) : Manual extraction of fetus in *parigha* or oblique lie (dorso-anterior or posterior position); one hand inside the uterus over the head of fetus and other over the abdomen of woman holding buttocks of fetus. Step—I head is pulled downwards and hips pushed upwards in (A) dorso-anterior, (B) or dorso-posterior positions; (C) step—II the head is brought further down to the exit passage.

ऊपर की ओर उछालकर (चि० २१ अ) सक्थियों को प्रसारित करके आहरण करें^{१,२} (चि० २१ ब एवं स)।

ई) तिर्यक् प्रसवित होते हुए गर्भ को घुमाकर या परिघ के समान तिर्यक् या तिरश्चीन (अनुप्रस्थ आसन) प्रसवित होते हुए गर्भ के पीछे के भाग (सिका प्रदेश) को ऊपर की ओर उछालकर आगे के भाग (शिर) को अपत्यपथ में लाकर ऋजुभाव में या सीधा करके आहरण करें^{१,२} (चि० २२ अ, ब, एवं स)।

उ) पार्श्वपवृत्तिशिर (पार्श्व में घूमे हुए शिर) वाले गर्भ के अंस (कंधे) को पीड़न करके ऊपर की ओर उछालकर शिर को अपत्यपथ में लाकर आहरण करें^{१,२}।

ऊ) दोनों बाहुओं से उत्पन्न होने वाले गर्भ की बाहुओं को अंसप्रदेश के पीड़न के द्वारा ऊपर की ओर दबाकर (या प्रवेश कराकर) शिर को अनुलोम करके आहरण करें^{१,२} (चि० २३)।

संक्षेप में वर्णन करने पर कह सकते हैं कि प्रथम तीन गतियों में गर्भ को सक्थियों या पैरों के द्वारा तथा बाद की तीन गतियों को शोषोदय में परिवर्तित करके प्रसवित कराना चाहिए^१। अन्तिम दो गतियाँ असाध्य हैं अर्थात् आहरण से प्रसव नहीं हो सकता उनमें शस्त्र का प्रयोग आवश्यक है^१।

गर्भ के विषम-स्थिति में स्थित विभिन्न अङ्गों को आच्छन्न (फैलाना या खींचना), उत्पीड़न (ऊपर की ओर धकेलना), समोड़न (दबाना), निक्षेप (नीचे की ओर धकेलना) तथा उत्क्षेप (ऊपर की ओर उछालना) आदि के द्वारा अनुलोम करके (अपत्यपथ में उचित अङ्ग को लाकर) सीधा करके हाथ के द्वारा आहरण करें^१, उदाहरणार्थ मुखोदय में ललाट का उत्क्षेपण या उत्पीड़न कर के ऊर्ध्वशिर को समोड़न या निक्षेप द्वारा नीचे लाकर प्रसवित करावें (चित्र २४)।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि स्त्री को नाभि के आकार की कुण्डलिका बनाकर उसके ऊपर बैठकर उसके जानुओं

नोट—सन्दर्भ पृष्ठ ५२२ में देखें।

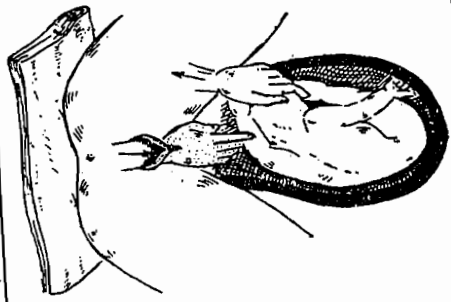


Fig. (23) : Manual delivery in *bījaka* or compound presentation. With the hand of surgeon inside the uterus the arm of fetus is pushed up and with another hand kept over the abdomen the head of fetus is pushed downwards

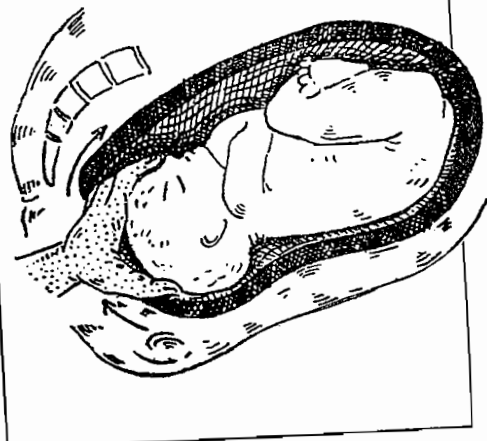


Fig. (24) : Manual delivery in *mukhodaya* or brow presentation. After *ulkshepa* or pushing the frontal portion of fetal head upwards the appropriate part or vertex is brought to the exit passage.

को फैलाकर पीठ के भाग को कुछ दबाकर उदर के भाग में गर्भ को नीचे की ओर अवतारित करावे या तबो। योनिद्वारा गर्भ के आ जाने पर तिल-तैल एवं जल से अभ्यङ्ग करके (वैद्य के हाथ एवं स्त्री की योनि का), हाथ को योनिद्वारा में डालकर तर्जनी एवं अंगुठी से गर्भप्रदेश को पकड़ कर गर्भ को बाहर निकालो।

१. तत्र सविश्रामागतमनुलोममेवाच्छेत् । एकसंख्या प्रकस्येतस्यैव प्रसायापहेत् । स्फिन्देशेनागतस्य स्फिन्देशे प्रपीड्यो-
ध्वमुत्क्षिप्य सविश्रामे प्रसायापहेत्, तिर्यगागतस्य परिधयेव तिर्यङ्गीनस्य पश्चादध्वमुत्क्षिप्य पूर्वार्धमपत्त्यपं प्रत्याज्ज्वमानो-
यापहेत्, पाश्चात्पर्वताग्रसमं प्रपीड्योध्वमुत्क्षिप्य शिरोऽपत्त्यपमानोयापहेत्, बाहुद्वयप्रतिपन्नस्योध्वमुत्क्षिप्यो
शिरोऽनुलोममानीयापहेत् ॥ (सु० सं० चि० १५/९)
२. तत्र सविश्रामागतमनुलोममेवाच्छेत् । एकस्मिन् सविश्रामे प्रकस्येत तं सविश्रामे प्रसायापहेत्, स्फिन्देशेनागतस्य स्फिन्देशे
प्रतिपन्नोध्वमुत्क्षिप्य सविश्रामे प्रसायापहेत्, तिर्यगागतस्य परिधयेव तिर्यङ्गीनस्य पश्चादध्वमुत्क्षिप्य पूर्वार्धमपत्त्यपं
प्रत्याज्ज्वमानोयापहेत्, पाश्चात्पर्वताग्रसमं प्रपीड्योध्वमुत्क्षिप्य शिरोऽपत्त्यपमानोयापहेत्, बाहुद्वय प्रकस्योध्वमुत्क्षिप्यो
शिरोऽनुलोममानीयापहेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/३९)
३. तत्र आद्यं मूढगर्भाद्वयं पादाभ्यामाहणीयं, तदितरं त्रितयं शिरसा, द्विविधं शेषं तु मूढगर्भसमाभ्याम् एवमर्धौ मूढगर्भाः ।
(सु० सं० चि० १५/९ को डलहं टीका)

४. सु० सं० चि० १५/९, अ० सं० शा० ४/४० (शस्त्रकर्माहं मूढगर्भाद्वयं चर्चिन्)
५. हस्तेन शक्यं तैवेव गर्भं च विषमं स्थितम् ॥ २७॥
६. आच्छेदोत्तरासम्प्राद्विशेषोत्प्रेषणार्थिभिः । अनुलोम्य समाकर्ष्योनिं प्रत्याज्ज्वान् ॥ २८॥ (अ० ह० शा० २/२९, २८)
७. तत्र शस्त्रकर्माहं भेषजानि भूषणं मे । नाभिद्विलग्न्याच्च सुकुण्डलिकां कृत्वा तु तस्योपरिमूढगर्भापुनरेवमनुलोमीसायं
किंचित्पुष्टभागो साधारणमवष्टप्य उदराद्योऽवतारयेत् ॥ योनिद्वारे प्रागति तिलतैलेन वारिणा परिच्यव्य हस्तो याति योनिद्वारा
तस्मात्तर्जनाङ्गुष्ठेन गर्भप्रदेशे धृत्वा निःसारयेत् ॥ (हो० सं० तु० स्था० ५/२१९)

The fetuses delivering with different positions/presentations should be extracted in following way—

Presentations/positions

Manipulations and extraction of fetus

- Both the thighs
Draw in the same or downward proper direction (fig. 19a, b).

- One thigh
First deliver another thigh (fig. 20a) then extract the fetus (fig. 20b).

- Buttocks

Dislodge the buttocks, push them upwards (fig. 21a), bring both the thighs downwards (fig. 21a) and deliver the fetus (fig. 21c).

- Oblique or transverse just like a wooden belt used to fasten the door
Push the back side or hips of the fetus upwards, bring the head downwards to the passage (fig. 22 a, b), straighten it and extract (cephalic version) (fig. 22c).

- Head moved to the lateral side (shoulder presentation)
Dislodge the shoulder, push it upwards, bring the head to the maternal passage and extract the fetus (cephalic version).

- Both arms
Push both the arms upwards by pressing the shoulder region, (fig. 23), bring the head down to the passage and extract the fetus.

In short, it can be said that in former three presentations delivery is to be completed with thigh or foot presentation, in latter three presentations cephalic version should be done and the fetus should then be delivered. In last two presentations (described under *gaikas*) manual extraction is not possible thus surgery has to be done.

The position of various abnormally situated fetal parts should be corrected by drawing, dislodging, compressing, pulling downwards, pushing upwards and bringing appropriate part to the maternal passage, then the fetus should be extracted, such as in face or brow presentation the frontal portion or forehead should be dislodged and pushed upwards then the vertex should be compressed and pulled downwards and delivery conducted (fig. 24).

Hārta says that after making the woman sit over circular pad with stretched or abducted thighs her back should be gently compressed and the fetus should be brought downwards in the abdomen. Once the fetus reaches vaginal passage, the hand lubricated with *tila* oil and water should be inserted in vagina already oiled with *tila* oil and water. Now the neck of fetus should be grasped with index finger and thumb and fetus extracted.

११) शस्त्रकर्माहं मूढगर्भं (The mūdhagarbha fit for instrumentation)

द्वान्ध्यावसाय्यौ मूढगर्भौ । एवमशक्ये शस्त्रमवचारायेत् ॥ (सु० सं० चि० १५/९)

यस्त्वाभुनमभ्यः पाणिपादशिरसिर्धर्मोनिं प्रतिपद्यते । यश्चाभुन एवैकेन पादेन योनिं द्वितीयेन पायुम् ।

तौ मूढौ हस्तेनार्तुमशक्याविति शस्त्रमवचारायेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/४०)

विषकम्भो नाम ते मूढौ शस्त्रदारणमर्हतः ॥ (अ० ह० शा० २/३०)

दोनों अन्त के मूढगर्भ असाध्य है इनमें असफलता मिलने पर (हाथ से आहरण करने में असफलता मिलने पर) शस्त्र का अवधारण करे।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने दोनों अन्तिम गतियों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जो बीच से आपुन होकर हाथ, पैर एवं शिर से योनि को प्राप्त होता है तथा जो आपुन होकर एक पैर से योनि तथा दूसरे से गुदा को प्राप्त होता है, ये दोनों हाथ से आहरण करने के योग्य नहीं होते हैं अतः इनमें शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि विषकम्भ नामक दोनों मूढगर्भ शस्त्र से दारण के योग्य होते हैं। टीकाकार अरुणदत्त ने स्पष्टीकरण दिया है कि इन दोनों प्रकार के मूढगर्भों को हाथ से खींचकर निकालना सम्भव नहीं होता अतः शस्त्र से दारण करना चाहिए।

भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर पुस्तकों में लिखा है कि गर्भ के मृत हो जाने पर (मर जाने पर) गर्भिणी को योनि में शस्त्र का प्रवेश करना चाहिए।

महर्षि काश्यप ने गर्भिणी स्त्री के अरिष्ट लक्षणों के वर्णन के साथ ही स्त्री को कुछ उन शारीरिक स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें गर्भ के प्रसव के लिए शस्त्र-कर्म आवश्यक होता है; जैसे—

जिस स्त्री की नासा कौए के समान हो जाय तथा जिसके नेत्र खरत हो जाय (कौएते हो या पलकें नीचे गिर जाय) तथा जिसमें शकुन पक्षी की गंध आती हो उस स्त्री के गर्भ का शस्त्र से मुंचन होता है अर्थात् वह शस्त्र से ही प्रसवित हो सकता है^३।

जिस स्त्री से बकरे या गोड़े की गंध आती हो, जो खेत (पाण्डु के कारण) हो गई हो; जो मोर का मांस खाते की इच्छा रखती हो उस स्त्री का गर्भ शस्त्र से ही निकलता है^३।

In last two positions or *gates* i. e. fetus either presenting with both the extremities and head together with body flexed in middle portion (back) or with one foot in vagina and other in anus, manual extraction of *mūḍhagarbha* is not possible, thus in these cases instruments should be used. *Bhāvaprakāśa* and *Yogarātnākara* opine that instrumentation should be done when the fetus is dead.

While enumerating bad prognostic clinical features of a pregnant woman *Kāśyapa* has enumerated two conditions in which delivery has to be completed with the help of instruments, these are—

a) The woman whose nose assumes the shape like a crow (crow's beak), eyes (eye lids) have drooped and emits the smell of *śakuntā* (a bird of prey), her fetus has to be delivered with the help of instruments.

b) The woman who emits the smell of goat or horse, has become white and desires

१. एतौ द्वौ विषकम्भौ नाम मूढौ-मूढगर्भौ, शस्त्रदारणमर्हतः। हस्तेनाकुटुम्बशब्दव्याख्यातयोः शस्त्रदारणं कार्यमित्यर्थः ॥ (अ० ह० शा० २/३० की अरुण टीका)

२. मृते तु गर्भे गर्भिण्या योनौ शस्त्रं प्रवेशयेत् ॥ (पा० प्र० चि० ७०/१२२ एवं यो० १० स्त्रीयो० चि०)

३. नासा तु काकवक्षस्याः सस्तनेना च या भवेत्। तथा शकुन्तास्या च गर्भः शस्त्रेण मुच्यते ॥ १७२ ॥

अजाक्षाया खेतो या मायूर मांसमिच्छति। गर्भस्तस्यापि शस्त्रेण नार्थं निह्नयेत् नृप। ॥ १७३ ॥ (का० सं० चि० १०)

to eat peacock's meat, her fetus can be delivered only with the instruments.

१२) सचेतन गर्भ के छेदन का परिणाम (The effect of rending or decapitation and other destructive procedures of alive fetus)

सचेतन च शस्त्रेण न कथञ्चन दारयेत्। दार्यमाणो हि जननीनामात्मानं चैव पातयेत् ॥

(सु० सं० चि० १५/१०)

सचेतनश्च गर्भः शस्त्रेण विदार्यमाणो विषममङ्गुलिं विक्षिपेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/३३)

छिन्नाट्ठगर्भं न जीवन्तं मातरम् स हि मारयेत्। सङ्गात्सना। (अ० ह० शा० २/३७)

सचेतन या जीवित गर्भ का कभी दारण (छेदनादि) नहीं करना चाहिए क्योंकि दारण करने से वह गर्भ माता को मार देता है तथा स्वयं भी मर जाता है। "जातयेति" शब्द को व्याख्या करते हुए टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि हस्ताभकषण के लिए असमर्थता होने के कारण यह गर्भ दोनों अर्थात् गर्भ एवं गर्भिणी के लिए विधिविकारक होता है^३। महर्षि सुश्रुत ने इस वर्णन के पश्चात् ही लिखा है कि असह्य विकार या व्यभिच हो जाने पर गर्भ का पातन श्रेयस्कर होता है, गर्भिणी का विचार्यार्थ न करके अर्थात् उसकी स्थिति को और गम्भीर न करते हुए चिकित्सा के लिए उपलब्ध काल (प्रासकाल) का उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए^३। इस वर्णन का अप्रत्यक्ष रूप से यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि यदि स्त्री की स्थिति गम्भीर हो रही है तथा मूढगर्भ का प्रसव मन्त्रादि या हस्ताभकषण से नहीं हो रहा तो स्त्री के जीवन की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार से गर्भ का पात करा देना अर्थात् उसे बाहर निकालना ही श्रेयस्कर है चाहे वह जीवित गर्भ ही क्यों न हो अर्थात् आन्ताधिक अवस्था में जीवित गर्भ का भी दारण कर सकते हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि चेतनायुक्त (जीवित) गर्भ का विदारण करने से वह अपने अङ्गों को विषमरूप से (चाँते ओर या असामान्य दिशा में) फेंकता है। टीकाकार इन्दु का मत है कि वह गर्भ स्वयं के ही साथ स्वसम्बन्धोष करके माता को भी मार देता है^३।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि जीवित गर्भ का छेदन नहीं करना चाहिए क्योंकि छेदन करने से वह माता को भी अपने ही साथ मार डालता है।

भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर के लेखकों ने महर्षि सुश्रुत का अक्षरशः अनुकरण किया है^४।

Alive fetus should never be split or cut, because due to rending the fetus kills the mother and dies itself.

Once the manual extraction fails the condition becomes dangerous for the mother and fetus both is the opinion of *Dalhāṇa*. *Suśruta* has further mentioned that if the disease or condition becomes very serious, the expulsion or delivery of fetus must be completed, one

१. घातयेदिति सर्वशैवाश्वहस्ताकर्षे द्वयोरपि गर्भगर्भिण्यार्विपत्तिरिद्विद्वेः ॥ (सु० सं० चि० १५/१० की डल्हण टीका)

२. अविषह्ये विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातनम्। न गर्भिण्या विपर्यस्तस्मात् प्रातं न हापयेत् ॥ ११ ॥

(शस्त्रमन्त्रादिनोपाधेनासिद्धौ गर्भव्यावनं गर्भिणीस्यैव कार्दीमित्याह-अविषह्य इति। सोऽङ्गुलान्वये विकारे व्याधौ सति किं कर्तव्यमित्याह-श्रेयो गर्भस्येति श्रेयो भवतीत्यर्थः। तस्मात् प्रासकालं न हापयेदोऽश्वयोदित्यर्थः-डल्हण)

(सु० सं० चि० १५/११ व डल्हण टीका)

३. विषमं कृत्वाङ्गुलिं विक्षिपन् निरुच्छ्वासोक्तुल्य जननीं हन्यादिति संबन्धः। (अ० सं० शा० ४/३३ की इन्दु टीका)

४. सचेतनं तु शस्त्रेण न कथञ्चन दारयेत्। स दार्यमाणो जननीनामात्मानं चापि मारयेत् ॥

(पा० प्र० चि० ७०/१२३, एवं यो० १० स्त्रीयो० चि०)

should not neglect the woman lest her condition deteriorates, thus should not waste or cross the limit of available (short) time. This verse indicates that if medicinal treatment and manual extraction has failed and the condition of woman is deteriorating, the delivery must be effected at the earliest, even one may have to split/destroy the alive fetus; or in other words during acute emergency alive fetus can also be destructed.

Vāgbhaṭa I says that when an alive fetus is cut, it throws its body parts all around abnormally (thus poses problem in extraction). Indu says that the mother dies due to asphyxia.

Bhāvaprakāśa and Yogaratnakara have expressed the views identical to Sūśruta.

१३) मूढगर्भ का शस्त्र-कर्म (Surgery or destructive operations for mūḍagarbha)

अ) सामान्य सिद्धान्त (General principles)

यद् यदङ्गं हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद् भिषक् । सम्यग्विनिर्हीर्यच्छित्त्वा रक्षेत्राग्निं च यन्ततः ॥ १३ ॥
गर्भस्य गतवाग्निना जायतेऽनिलकोपतः । तत्रान्त्यमतिर्वैद्यो वर्तेत विधिपूर्वकम् ॥ १४ ॥
मण्डलाग्रेण कर्तव्यं छेदमन्तर्विधानतः । वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णान् गर्तां हिंस्यात् कदाचन ॥ १६ ॥
(सु० सं० चि० १५/१३, १४, १६)

यद्यद्वायुवशादङ्गं सज्जेद्गर्भस्य खण्डशः । तत्तच्छित्त्वा हेतुसम्यग्क्षेत्राग्निं च यन्ततः ॥
(अ० सं० शा० ४/४२, ४३)

मण्डलाङ्गुलिशस्त्राभ्यां तत्र कर्म प्रशस्यते ॥ ३० ॥
वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णान् न योनाववाधारेत् ॥ ३१ ॥

यद्यद्वायुवशादङ्गं सज्जेद्गर्भस्य खण्डशः । तत्तच्छित्त्वाऽऽहेतुसम्यग्, रक्षेत्राग्निं च यन्ततः ॥ ३२ ॥
गर्भस्य हि गतिं चित्रां करोति विगुणोऽनिलः । तत्रान्त्यमतिरसमादवस्थापेक्षमाचरेत् ॥ ३६ ॥
(अ० ह० शा० २)

वैद्य को स्त्री को यत्नपूर्वक रक्षा करते हुए गर्भ का जो जो अङ्ग संसक्त हो रहा हो (या मार्ग में आकर अवरोध उत्पन्न कर रहा हो) उस अंग का छेदन करके भलीभाँति निकालना चाहिए। वायु के प्रकोप के कारण गर्भ को विचित्र (अनेकों प्रकार की) गतिवाई हो जाती है। बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि विधिपूर्वक कार्य करे। ज्ञाता वैद्य मण्डलाग्र शस्त्र से अन्तर का (अन्तर्स्थित गर्भ का) छेदन करे। वृद्धिपत्र के तीक्ष्ण होने के कारण स्त्री की प्राण-हानि की सम्भावना रहती है (स्त्री के अन्तर के अङ्गों यथा गर्भाशय या आन्त्र आदि में आघात होने से मृत्यु की सम्भावना रहती है)।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि वायु के कारण गर्भ का जो जो अङ्ग संसक्त हो रहा हो (अपत्यमार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा हो) उसे स्त्री को रक्षा करते हुए खण्ड-खण्ड काटकर यत्न-पूर्वक भलीभाँति बाहर निकालना चाहिए।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि मण्डलाग्र एवं अङ्गुलिशस्त्र (चि० १८) के द्वारा यह कर्म (गर्भशूलोद्धरण) प्रशस्त होता है, वृद्धिपत्र को तीक्ष्ण होने के कारण योगिनि में प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। वायु के कारण (गर्भ का) जो जो अङ्ग संसक्त हो रहा हो उसे यत्नपूर्वक स्त्री को रक्षा करते हुए खण्ड-खण्ड काटकर भलीभाँति आहरण करना चाहिए। अनिल को विगुणता के कारण गर्भ को अनेकों विचित्र गतिवाई होती है अतः बुद्धिमान वैद्य को अवस्थानुसार कर्म करना चाहिए।

भावप्रकाश एवं योगरत्नकारकार ने अष्टाङ्गसंग्रह का अक्षरशः पालन किया है।^१

१. यद्यदङ्गं हि गर्भस्य यौनौ संसक्तं तु तद्विषयकं । सम्यग्विनिर्हीर्यच्छित्त्वा रक्षेत्राग्निं प्रयन्ततः ॥ (पा० १० चि० ७०/१२५)
यद्यदङ्गं.....सज्जति तद्विषयकं । ॥ (भावप्रकाश सट्टय) (यो० १० स्त्रीसं० चि०)

The surgeon protecting the woman very carefully should split/cut the part of the fetus which is fixed or is producing obstruction. The fetus has various abnormal presentations/positions due to aggravation of vāyu. Taking cognizance of this fact the surgeon should take appropriate decisions and deliver the fetus. The wise surgeon should destruct this inside situated fetus with the help of *mandalāgra* or *aṅguli śāstra*. (fig 18); with the use of *vrddhipatra* which is very sharp edged instrument there is risk of maternal death (due to injury).

अ) मूढगर्भ के शस्त्र से छेदन की विधि (Method of destruction/decapitation of the fetus)

स्त्री को आश्वसन देकर मण्डलाग्र अथवा अङ्गुलि शस्त्र से^{१,२,३}—

१) सर्वप्रथम शिर का विदारण करके (चि० २५ अ) शिर के कपालों (कपालस्थियों) का आहरण कर (चि० २५ ब) शंक्रु (चि० १८) से ऊर, कक्षा^१, चिबुक एवं तालु को^{२,३} पकड़कर आहरण करें^{१,२,३}।

After assuring and encouraging the woman the surgeon with the help of *mandalāgra* or *aṅguli śāstra* should—

i) After perforating the head (bregma, vertex or any other central part of head i.e. craniotomy) (fig. 25a) and subsequently extracting the flat bones of skull (fig. 25b) the surgeon should grasp the chest, axilla, chin or palate with the *śānika* (hook) and extract the fetus.

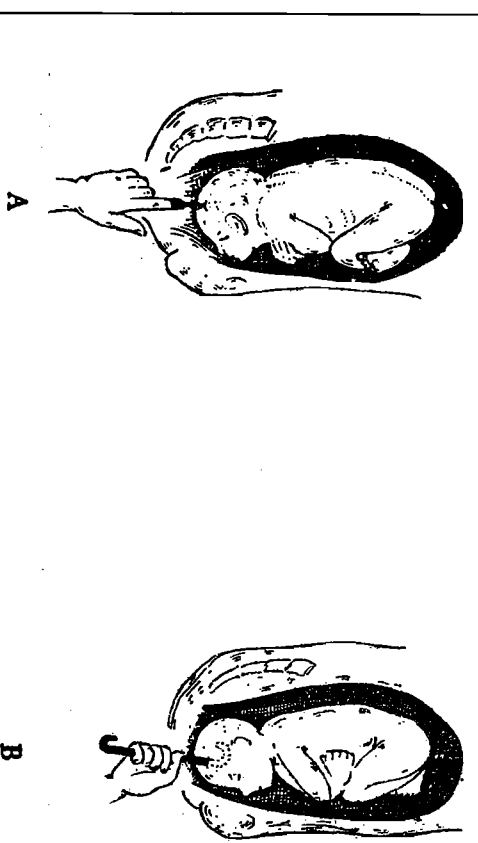


Fig (25): Craniotomy in a case of obstruction due to *śira* or head (brow presentation). (A) the bregma is perforated with *aṅguli śāstra*; (B) then flat bones of head are extracted with *śānika* (hook).

२) शिर का विदारण न होने पर अक्षिकूट (चि० २६ अ) अथवा गण्ड (शंखप्रवेश) (चि० २६ ब) के द्वारा (इनक विदारण करके अथवा इनको पकड़कर आहरण करें)^{१,२,३}।

नोट—सन्तर्भ पृष्ठ ५२९ में देखें।

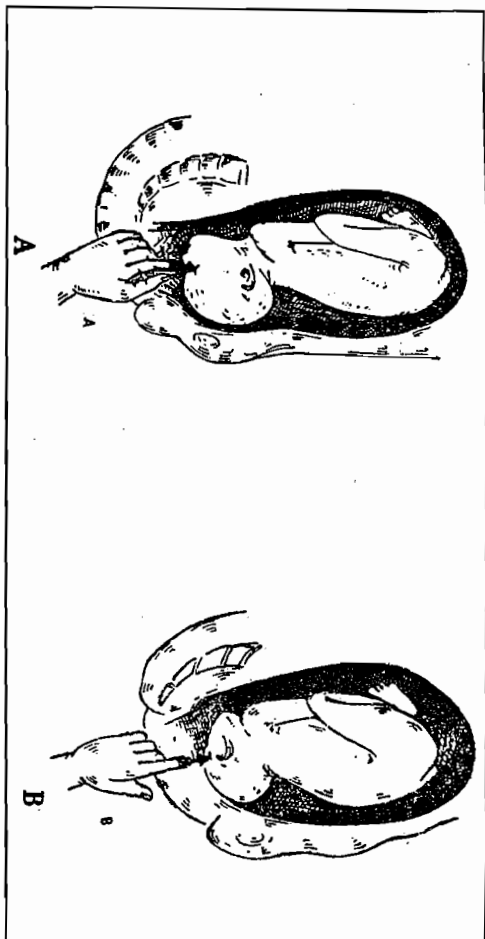


Fig (26) : Craniotomy in *mukhodaya* i.e. face or temporal presentation. (A) eye ball or (B) temporal region is perforated with *angulīśāstra*.

ii) In case of inability in rending (perforating) the head, *akṣikūṇa* (hallow of eyeball) (fig. 26a) or *śankhapradeśa* (temporal region) (fig. 26b) should be perforated (craniotomy) and fetus extracted.

३) अंस या कंधे से सक्त होने पर स्कन्ध देश से बाहु को काटकर (चि० २७ अ एवं ब) आहरण करें^{१,३,३} (चि० २७ स) ।

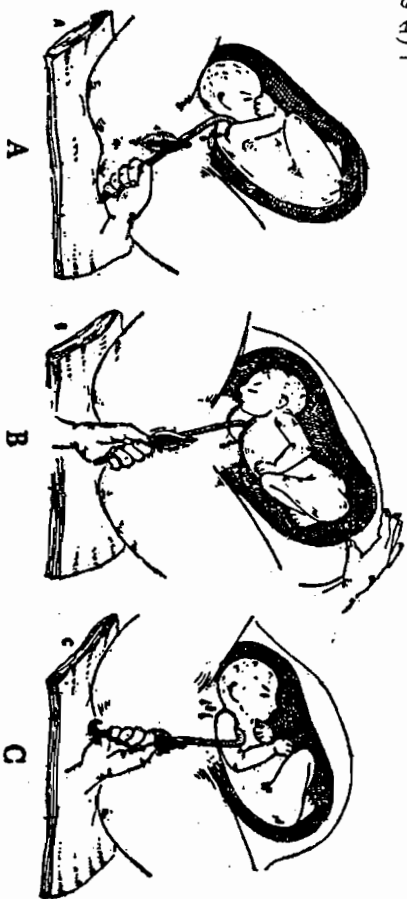


Fig (27) : Destructive operation in *tiryaka-gūṇa* or shoulder presentation. The arm is cut with the help of *maṇḍalāgra śāstra* from the region of shoulder in (A) dorso-anterior or (B) dorso-posterior positions (C) the cut arm is hooked with *śanku* (hook) and extracted.

नोट-सन्दर्भ पृष्ठ ५२९ में देखें ।

iii) In obstruction being caused due to fixation of *amśa* (shoulder), the arm should be cut from the region of shoulder (fig. 27a&b), delivered and fetus extracted (fig. 27c).

४) दृति (मशक) को भाँति फूले हुए वात-पूँ उदर को विदारण करके (चि० २८) आन्त्रों के निकल जाने से शिथिल (उदर के) हो जाने पर आहरण करें^{१,३,३} ।

iv) In case of obstruction being caused due to abdomen full of *vāta* (gases) and distended like *dri* (leathern bag for holding water), the abdomen should be split (perforated-evisceration) (fig. 28). After abdomen becomes soft due to protrusion of intestines, the fetus should be extracted.

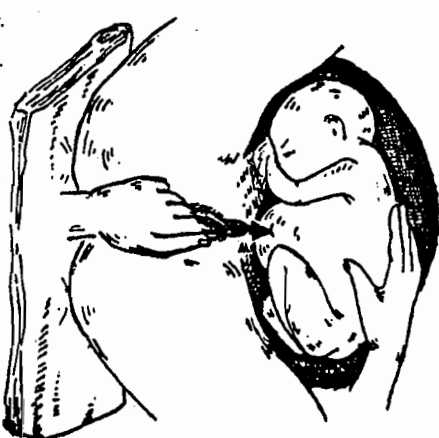


Fig (28) : Evisceration in a case of obstruction due to *Jajihara* or distended abdomen. The abdomen is perforated with *angulī śāstra*.

५) जंघा^{१,३} या कटि^३ से सक्त होने पर जघनकपालों (निम्नबास्थियों) को विदीर्ण करके प्रसव कार्यों^{१,३,३} । (चि० २९ अ एवं ब)

v) When the obstruction is due to fixation of thighs or hips, then hipbones should be split and fetus extracted. (fig. 29a & b).

१. ततः स्त्रियमाश्वस्य मण्डलाग्रेणकुलीशस्त्रेण वा शितो विदार्य, शिरःकपालाभ्याहृत्य, शङ्कुना गृहीत्वोरिस कक्षायां वापहरेत्; अभिगिरिसमक्षिकृदे गाढे वा, अंससंसकस्यांसदेशे बाहुं छित्त्वा, दृतिमिवातं वातपूर्णोदरं वा विदार्य निरस्यान्नाणि शिथिलीभूतमाहरेत्; जघनसकस्य वा जघनकपालानीति ॥ (सु० सं० चि० १५/२२)

२. अथ स्त्रियमाश्वस्य मण्डलाग्रेणकुलीशस्त्रेण वा विदार्य शिरःकपालाभ्याहृत्य शङ्कुना गृहीत्वा चुबुके तानुयुरिस कक्षायां वापहरेत् । अभिगिरिसं त्वक्षिकृदयोगाण्डयोगेति । बाहुं छित्त्वा दृतिरिवाभ्यातस्य वातपूर्णमुदरम्वदार्य निरस्यान्नाणि शिथिलीभूतमाहरेत् ॥ जघनसकस्य जघनकपालानि दारिद्वजेति ॥ (अ० सं० शा० ४/४१)

३. पूर्वं शिरः कपालानि दारिद्वजा विभोषयेत् ॥ ३१ ॥

कक्षोत्सलानुचक्रप्रदेशेऽन्यत्वे ततः । समालम्ब्य दृढं कर्षेत्कुशलो गर्भशङ्कुना ॥ ३२ ॥

अभिगिरिसं त्वक्षिकृदयोगाण्डयोगेति । बाहुं छित्त्वाऽंससकस्य वातप्रभातोदरस्य तु ॥ ३३ ॥

विदार्य कोष्ठमन्नाणि बहिर्वासं निरस्य च । कटीसकस्य त्वच्च तत्कपालानि दारिद्वजे ॥ ३४ ॥

(अ० ह० शा० २/३१ से ३४)

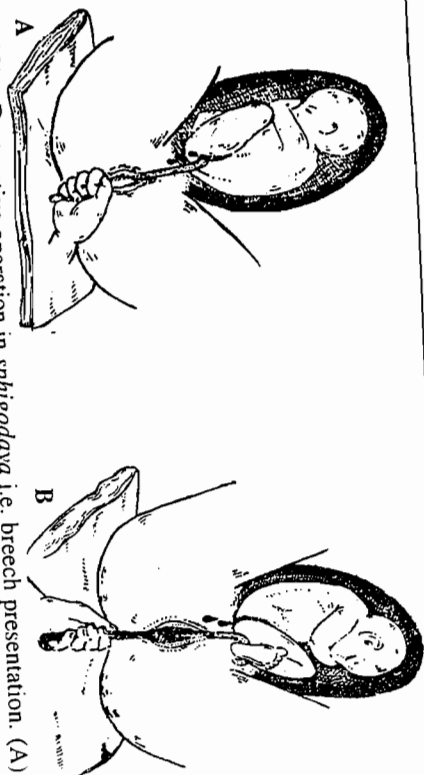


Fig (29) : Destructive operation in sphigodya i.e. breech presentation. (A) hip bones are cut near the thighs with *mandalagra śastra*; (B) cut leg is hooked with *sanku* (hook) and extracted.

संक्षेप में जिस जिस अङ्ग से गर्भ अवरोध उत्पन्न कर रहा हो उसे काटकर प्रसव करावे ।

महर्षि हरित ने संक्षेप में लिखा है कि अर्द्धचन्द्र शस्त्र के द्वारा मूल-गर्भ की दोनों बाहुओं का छेदन कर प्रसव करावे^१ । In summary, it can be said that what-so-ever part of the fetus is creating obstruction, same should be cut/split and fetus extracted.

Hārīta says that with *ardhachandra śastra* both arms of fetus should be cut and fetus extracted.

१४) मूढगर्भ शल्योद्धरण के पश्चात् कर्म (Post-operative management of mūḍhagarbha)

मूढगर्भ के निकल जाने के बाद:-

१) पूर्ववर्णित उपायों (पृष्ठ ४५८ से ४६४) से न निकलती हुई अपरा का पातन करावे^{१,२,३} ।

२) इस प्रकार शल्य (मूढगर्भ तथा अपरा) निकल जाने के बाद उस स्त्री को उष्ण जल से अवसिंञ्चन करावे (धुलाकर स्नान करे) तथा देह का अभ्यङ्ग (तेल का मर्दन) करके योनि में स्नेह (तेल) की पिचु धारण करावे । यह करने से योनि मृदु हो जाती है तथा शूल का भी शमन होता है^{१,२,३,४,५} ।

३) निम्नांकित औषधियों का प्रयोग करें-

अ) कृष्णा, कृष्णामूल, शुण्ठी, एला, हिंगु, भाङ्गी, दीपका, वचा, अतिविषा, रास्ना तथा चव्य को चूर्ण करके स्नेह (तेल) के साथ रक्त तथा क्लेतादि^६ दोषों के बाहर निकालने, पार्श्व एवं योनि^७ की वेदना तथा काठिन्य^८ की शान्ति के लिये पिलावे, अथवा इन्हें औषधियों का स्नेह विरहित क्वाथ, कल्क या चूर्ण प्रयोग करें^१ ।

आ) शाकवक्, हिंगु, अतिविषा, पाठा, कटुकरोहिणी तथा तेजोवती के चूर्ण को पूर्वोक्त विधि से प्रयोग करावे^{१,२,३}

(दोष निष्कासन तथा वेदना-शमनार्थ)^१ ।

१. अथवार्द्धचन्द्रेण शस्त्रेणैव मृतागर्भस्य बाहुगुलां संच्छिद्य बाहू निःसारयेत् ॥ (हो० सं० तृ० ५/२/१७)

नोट - मूढगर्भ-शल्योद्धरण के पश्चात्कर्म के सन्दर्भ पृष्ठ ५३१ व ५३२ में देखें ।

इ) दीपका, अतिविषा, रास्ना, हिंगु, एला एवं पञ्चकोल के चूर्ण, कल्क या क्वाथ को स्नेह (घृत) के साथ पान करावे^{३,४} ।

इ) शिरीष एवं कज्जुर का क्वाथ आचमन के लिए हितकर है^१ । इसका पिचु योनि में धारण करना चाहिए^{३,४} ।

उ) वायु का श्मन करने के लिए योनि-सन्तर्पण, अभ्यङ्ग, पान, बस्ति एवं भोजन के रूप में बलातैल हितकारी है । बलातैल की ही भाँति (अभ्यङ्ग, पान, पिचु एवं बस्ति आदि में) शतपक्का बलातैल, अतिबला, गुडूचि तथा नीलोत्पल आदि से निर्मित तैल का प्रयोग करें^१ ।

४) विभिन्न औषधियों एवं पथ्यों का प्रयोग-काल निम्नांकित है । उपर्युक्त (अ, आ एवं इ के अन्तर्गत वर्णित औषधियों का प्रयोग तीन^{१,२,३} पाँच^४ या सात^{५,६,७} दिन तक तत्पश्चात् स्नेह पान एवं सायंकाल सुसंस्कृत आसव या अग्नि का पान करना चाहिए (अर्थात् प्रातःकाल स्नेह पान एवं सायंकाल आसव, अग्नि का पान करना चाहिए)^८ । तत्पश्चात् एक दशाह (पूर्ववर्णित दस दिन के पश्चात्) वागहर औषधियों से सिद्ध दुग्ध-पान एवं उसके पश्चात् एक दशाह तक मांस रस का प्रयोग करना चाहिए । बाद में (इस प्रकार तीन दशाह अर्थात् एक मास के पश्चात्) सिन्धु, लघु एवं पथ्य अल्प भोजन, स्नेह, बलातैलादि का अभ्यङ्ग एवं अन्य स्नेह (पिचु, बस्ति, पान के रूप में) का प्रयोग चार मास तक करना चाहिए^{१,२,३} उसे इस काल में क्रोध नहीं करना चाहिए । उपर्युक्तों से रहित, विशुद्ध, बल एवं वर्ण से युक्त हो जाने पर चार मास के पश्चात् यह पथ्य विधि छोड़ दे^९ तथा क्रमशः अन्य सुखों का उपभोग करें^{१,२,३} ।

टीकाकार डल्हन का मत है कि उपर्युक्त प्रकल्प-विधि प्रसव-काल में ही उत्पन्न (पूर्व) प्रालम्भ गर्भ में उत्पन्न) मूढगर्भता में गर्भ एवं अपरा के निर्हरण के पश्चात् की है । अकाल मूढगर्भा (अप्रालम्भ सिन्धु या चौथे पाँचवें मासादि) में स्त्री को शल्य-निर्हरण के पश्चात् केवल लंघन करारक उद्दालक आदि अजों की स्नेह एवं त्वण विरहित यवगू जिनसे मांस का गर्भ हो उतने दिन तक पीने को दें । अनन्तर मांस (ससम, अष्टम आदि) में उपर्युक्त वर्णित स्नेहादि का विधान अकाल मूढगर्भा में भी करें^९ ।

१. अथपातनीमपरां पात्रयेत् पूर्वो भिषक् । ॥ १७॥

एवं निर्हतशल्या तु सिञ्चिदुष्णेन वारिणा । ततोऽप्यक्तशरीराया योनौ स्नेहं निधापयेत् ॥ १८॥

एवं मूढीभवेद् योनिस्तच्छूलोपशाम्यति । कृष्णान्तमूलशुण्ठयेला हिङ्गुभाङ्गीः सदीपकाः ॥ २०॥

वचामतिविषां रास्नां चव्यं संचूर्ण्य पात्रयेत् । स्नेहेन दोषस्यन्दार्थं वेदनाशमाय च ॥ २१॥

क्वाथं चैषां तथा कल्कं चूर्णं वा स्नेहवर्जितम् । शाकत्वषिष्यवतिविषापाठाकटुक्रोहिणीः ॥ २२॥

तथा तेजोवती चापि पात्रयेत् पूर्वोद् भिषक् । त्रिरात्रं पञ्चसप्ताहं ततः स्नेहं पुनः पिबेत् ॥ २३॥

पात्रयेतासत्वं नक्तमग्निं वा सुसंस्कृतम् । शिरीषकज्जुराभ्यां च तोयमाचमने हितम् ॥ २४॥

उपद्रवाञ्च येऽन्ये स्युस्तान् यथास्वमुपाचरेत् । सर्वतः परिशुद्धा च सिन्धुष्वथाल्पभोजना ॥ २५॥

स्वेदाभ्यङ्गपाना नित्यं भवेत् क्रोधविबर्जिता । पयो बलहरैः सिद्धं दशाहं भोजने हितम् ॥ २६॥

रसं दशाहं शेषे तु यथायोगमुपाचरेत् । व्युष्रवां विशुद्धां च जाला च बलावर्णिनीम् ॥ २७॥

उर्ध्वं चतुर्थां मासेभ्यो विसृजेत् परिहृताः । योनिस्तन्पण्डित्यहं पाने वस्त्रिषु भोजने ॥ २८॥

बलातैलमिदं चास्ये दद्यात्तैलवारणम् । बलामूलकभायस्य ॥ २९॥धनिन्ध्यापि ये नराः ॥ ३०॥

बलाकाशयणीभ्यः ॥ ४०॥प्रकीर्तितः ॥ ४३॥

बलाकल्पेनातिबला ॥ ४४॥

नीलोत्पलं ॥ ४५॥

सर्वेषामेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः । बलातैलवदेतेषां गुणांश्चैव विशेषतः ॥ ४७॥ (सु० सं० चि० १५/१७, १९ से ४७)

क्रमशः

- ५) (इस काल में उत्पन्न) उपद्रवों की यथाविधि चिकित्सा करें^{१,२,३} ।
- ६) महर्षि चरक वर्णित (पृष्ठ ४७७) मूत्रार्थ-शस्त्रोद्धारण के पश्चात् की चिकित्सा का भी प्रयोग करना चाहिए ।
- ७) मूत्रार्थ निकल जाने के पश्चात् स्वेदन कर्म लाभदायक है^१ । विशेषकर उपद्रव रहित स्त्री का स्वेदन करें ।
- ८) कष्ट से प्रसव वाली स्त्री को शीतल जल पय्य है^{१०} ।
- After extracting the fetus following management should be done—
- i) Placenta should be delivered with the methods already described.
- ii) After expulsion of fetus and placenta, the woman should be irrigated with hot water (for cleansing), then her body should be massaged (with oil) and tampon of fat (oil) should be placed in vagina. With this treatment her yoni (vagina) becomes soft and pain subsides.
- iii) Following drugs should be used—
- a) Powdered *kṛṣṇā, kṛṣṇāmlā, śūṣhī, elā, hīṅgu, bhāṅgū, āpyakā, vacā, ativiṣā,*
२. अथापत्नीमयां पातयेत्पूर्ववद्विषक । एवं निर्हृत्शल्यां च सिञ्चेदुष्णो न वारिणा ॥ ४३ ॥
दद्यादप्यक्तदेहस्यै योनौ स्नेहापिबुं ततः । योनिर्मुहुर्भवेत्तेन शूलं चास्याः प्रशाम्यति ॥ ४४ ॥
दीप्यकतिविशाम्नाहिङ्ख्वेलापञ्चकालकात् । चूर्णं स्नेहेन कल्कं वा क्वाथं वा पायेदेषा ॥ ४५ ॥
कटुकातिविषापाठाशकत्वविषङ्गुलिनीः । तद्रुचं दीप्यन्दायै वेदजोषणमाय च ॥ ४६ ॥
शिरात्रमेव सप्ताहं स्नेहेन ततः पिवेत् । सायं पिवेदतिष्ठं च तथा मुहुनतमसम् ॥ ४७ ॥
शिरिकककुम्भकाशीपिचू योनौ च निक्षिपेत् । उपद्रवाश्च येऽन्ये स्मृतस्यान्यासम्पुत्रोत्तरे ॥ ४८ ॥
पयो वातहर्तैः सिद्धं दशाहं भोजने हितम् । स्रोते दशाहं च परं तनुपथ्यास्तभोजनो ॥ ४९ ॥
स्वेदाप्यङ्गुपात स्नेहात् बलातैलादिकान् भवेत् । ऊर्ध्वं चतुर्ध्व्यो मारेष्वप्यः सा क्रमेण सुखिणि च ॥ ५० ॥ (अ० सं० शा० ४)
३. अथापत्नीमयां । एवं निर्हृत्शल्यां तु सिञ्चेदुष्णो न वारिणा ॥ ३९ ॥
दद्यादप्यक्तः । प्रशाम्यति ॥ ४० ॥
दीप्यका । पायेततः ॥ ४१ ॥ कटुका । वेदजोषणमाय च ॥ ४२ ॥
त्रिपात्रव सुखिणि च ॥ ४३ ॥ सें ४६ ॥ (अ० सं० सदृश ही) (अ० ह० शा० २/३९ से ४६)
४. एवं निर्हृत्शल्यां तां स्नेहं विधारयेत् ॥ १२६ ॥
एवं मुष्टीभवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति ॥ (सु० सदृश ही) (भा० प्र० चि० ७०/१२६, १२७)
५. एवं स्नेहं निधापयेत् ॥ एवं शाम्यति ॥ (भा० प्र० सदृश ही) (यो० १० स्त्रीरोग चि०)
६. एवं सायमतिष्ठं प्रातः स्नेहे पीते । (अ० सं० शा० ४/४७ की इन्द्र दीका)
७. प्रसवकाल एवं ज्ञातमूत्रार्थः कृतकर्मणापहतापयाः पायवर्धनीशूलकातिन्याशास्तयै रक्तकलेदादिदोषप्रसेकार्थं च तैलाकयोस्तेनैव कृष्णादिपानम्, अकालमूत्रार्थमासु तन्निहायाः पुनरालकाले उद्दालकादीनामन्नामसहैल-वर्णाभिर्वाप्यभिरुपचारो यावन्तो मासा गर्भस्य तत्त्वन्वेवाहतिः अनन्तरमासे तु स्नेहादिविधानमकालतद्वर्णार्था अपि पूर्ववत् ॥ (सु० सं० चि० १५/२० से २८ को इल्लण ज्ञाख्या)
८. पश्चात्स्वेद्या गते शस्ये मूत्रार्थमतिरे तथा । काले प्रजाताडकाले वा पश्चात्स्वेद्या नितीव्यनी ॥ (शा० सं० ३० २/८)
९. पश्चात्स्वेद्या हते शस्ये मूत्रार्थानुपद्रवा ॥
सम्पक् प्रजाता काले वा पश्चात्स्वेद्या विजानता ॥ (सु० सं० चि० ३२/१८)
१०. क्लेशात् प्रसूते रुचिता च या स्त्री । ॥ ३६ ॥
..... तेषां जलं शीतमुशानि पयम् ॥ ४० ॥ (का० सं० कल्य० ७)

rāsānā and *carya* should be prescribed with fat preferably oil for relief of pain and rigidity of vagina and flanks and excretion of *rakta* (blood) and *kletā* (moisture) etc. *dosas*. Alternatively decoction, paste or powder of these drugs without fat (*ghṛta* or oil) can also be used.

b) For relief of pain and excretion of *dosas* powdered stembark of *śāka, hīṅgu, ativiṣā, pāihā, kaṭukarohiṇ* and *rejovāt* be prescribed with the method described supra.

c) Powder, paste or decoction of *āpyakā, ativiṣā, rāsānā, hīṅgu, elā* and *pañcakola* should be prescribed with *ghṛta*.

d) Decoction of *śirīṣa* and *kakubha* is beneficial if held in mouth. Tampon soaked with this should be placed in vagina.

e) For suppression of *vāyu* use of *balāitāla* in the form of tampon or vaginal irrigation (*yoni-santrapana*), massage, tisane, enema and with diet is beneficial. Just like *balāitāla*, others such as *śatāpāka balāitāla* and oils prepared with *aibālā, guāduci* and *nīlotpala* etc. can be used.

iv) Duration of use of drugs and congenial diet is as follows—

For three, five or seven days medicine described above (under 3a, b, c), then in the morning fat (medicated *ghṛta* or oil) and in the evening well treated *āṣava* and *ariṣṭa* should be given (total 10 days). For subsequent ten days milk medicated with the drugs capable of suppressing *vāta*, then for another ten days meat soup should be prescribed. After this period (three groups of ten days each i. e. one month) use of unctuous, light and congenial diet in little quantity, sudation, and use of *balā* etc. oils as massage, tampon, enema or tisane should be continued for four months (total four months or diet etc. for further 3 months). During this period she should avoid anger. After relief from complications and attainment of proper strength and complexion within these four months, she should discontinue this congenial mode and enjoy other pleasures of life.

Dalhana has clarified that above procedure is applicable in cases of extraction of full term fetus. In case of *mūdhagarbha* of fourth, 5th or 6th month of pregnancy, after extracting the fetus only fasting followed by fat and salt-free gruel made of *uddālāka* etc. cereals should be prescribed for the number of days corresponding to the duration of pregnancy in months (i. e. 4th month pregnancy then four days treatment). After this period i. e. in seventh and eighth month the procedure described above should be prescribed.

v) Complications arising during this period should be managed with appropriate measures.

vi) The treatment described for intrauterine dead fetus by Caraka can also be used.

vii) Use of sudation is beneficial, specially to the one who is free from complications.

viii) Use of cold water is congenial.

५५) शल्योद्धारण के पश्चात् चिकित्सान्तर्गत प्रयुक्त बलादि तैलों का वर्णन (*Description of bala etc. oils used in post-operative management of mūḍhagharbhā*)

१) बला तैल (*Balātāila*)—

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि बलामूल कषाय, यव, कोल एवं कुलस्थ का कषाय, दशमूल कषाय तथा दुग्ध प्रत्येक ८-८ भाग अर्थात् ३२ भाग द्रव्यों में एक भाग स्नेह (तैल का) मिलाने^१। टीकाकार डह्लण ने प्रक्षेप द्रव्यों को स्नेह के चतुर्थांश मिलाने का निर्देश दिया है^२। अष्टाङ्गसंग्रह^३ एवं अष्टाङ्गहृदय पुस्तकों में बलामूल कषाय एवं दुग्ध ६-६ भाग (कुल १२ भाग), यव, कोल एवं कुलस्थ तथा दशमूल सब का कषाय मिलकर एक भाग तथा एक भाग स्नेह लेने का विधान है। प्रक्षेप द्रव्यों में कुछ मत वैभिन्न्य है। काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्गापर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, मधुगण्डी, सैधव, अगर, देवदार, मञ्जिष्ठा, चन्दन, कुष्ठ, कालानुसारिका, शैलेयक, तेजपत्र, तगर, सारिवा, वचा, शतावरी, अश्वगंधा, शतपुष्पा, एला तथा पुनर्नवा द्रव्यों का वर्णन तीनों ही आचार्यों ने किया है^{४,५,६}। (अष्टाङ्गहृदय ने शूर्पपर्णी गूद जो मुद्गा एवं माषपर्णी दोनों का द्योतक है प्रयुक्त किया है)।

उपयुक्त द्रव्यों के अतिरिक्त महर्षि सुश्रुत ने छिन्नहस्त, मुद्गीका, कर्कटशृंगी, गुणाक्षीरी, पत्रक, प्रमोपडरीक, ऋद्धि, वृद्धि, जीवन्तो (मधुर अर्थात् कालकोल्यादि गण के शेष द्रव्य), सर्बर्षस, सरल तथा जटामांसी द्रव्यों का उल्लेख किया है।

अष्टाङ्गसंग्रह में क्षीरशुक्ला, वरा (त्रिफला) लवङ्ग, सरल, रस (बोल) तथा बला का वर्णन है^७।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी क्षीरशुक्ला, वरा (त्रिफला) तथा लवङ्ग के साथ रस (बोल) का वर्णन किया है^८। उपयुक्त वर्णित कषायादि एवं तैल में प्रक्षेप द्रव्यों का कल्क मिलकर मुद्ग अग्नि^{३,४} में या भलीभाँति^१ पाक कर सिद्ध हो जाने पर^{१,३,४} सोने चाँदी या मिट्टी^१ के पात्र में भर कर गूँथ स्थान^{१,३} या सुरक्षित स्थान में रखें, इस तैल का नाम बलतैल है। महर्षि धन्वन्तरि से यह तैल स्तुत्य है। इस तैल का निर्माण राजा या राजा की कोटि के मनुष्य, सुखी, सुकुमार तथा धनी व्यक्तियों के लिए करना चाहिए^१।

महर्षि शार्ङ्गधर ने बलतैल को सूतिका के लिए पथ्य माना है चूँकि नाम एवं घटक लगभग एक से ही है अतः काश्याय द्वारा धार्मीचिकित्सान्तर्गत वर्णित बलतैल इस बलतैल से पूर्णतया भिन्न है अतः काश्याय-वर्णित बलतैल का धार्मीचिकित्सा के अन्तर्गत वर्णन किया जाएगा।

This oil has been described by Suśruta and both the Vāgbhaṭas. Śāringadhara has prescribed this oil to a puerperal woman. Since the ingredients and uses are similar to certain extent, hence the same is also being described here. Kāśyapa has also prescribed *balātāila* for the treatment of diseases of wet-nurse, that being entirely different is not recapitulated here.

Ingredients—

There is some difference of opinion regarding constituents and their proportion amongst various authors, however, drugs used as basic decoction are identical as given

नोट - सन्दर्भ पृष्ठ ५३६ में देखें

hereunder—

a) Decoction—

Suśruta and Śāringadhara	Both Vāgbhaṭas
Decoction of root of <i>bala</i> , <i>daśamūla</i> and milk each eight parts (total 24 parts) decoctions of <i>yava</i> , <i>kola</i> , <i>kulatila</i> all together eight parts and oil one part.	Decoction of root of <i>bala</i> and milk each six parts (total 12 parts), decoctions of <i>yava</i> , <i>kola</i> , <i>kulatila</i> and <i>daśamūla</i> all together one part and oil one part.

b) Drugs—

Drugs described by all—*Kākolī*, *kṣīrakākolī*, *jīvaka*, *ṛṣabhaka*, *medā*, *mahāmedā*, *śaindhava*, *agaru*, *devadaru*, *mañjiṣṭhā*, *kusṭha*, *kāṭmāsāṇvīṇā*, *śāileyaka*, *tejaparra*, *tagara*, *sāriwā*, *vacā*, *śāitāwārā*, *aśwagandhā*, *śatapuspā*, *elā* and *punarnavā*.

Additional drugs described by Suśruta and both Vāgbhaṭas—*Mudgaparāṇī*, *māṣaparāṇī*, *mādhuyasī*, *candana* and *saralā*.

Drugs described only by Suśruta—*Chinnaruhā*, *karkatāśṅgū*, *tuṅgākṣīṇī*, *padmaka*, *prapaṇḍarīka*, *mṛdwikā*, *jīvanī* and *sarjaraśa* (not in AH).

Drugs described by Suśruta and Śāringadhara—*Rādhi*, *vṛddhi*, *jātāmāṁsī*.

Drugs described by both Vāgbhaṭas—*Kṣīrasūkā*, *twak*, *varā* (*triphalā*) and *rasa* (*bola*) with *bala* (by Vāgbhaṭa I).

Method of preparation—

All the drugs (described under b) together should be taken in 1/4 quantity of oil. The decoctions (described under a) and oil should be mixed with the paste of these drugs and cooked in low fire. When oil is properly prepared this should be filled in the pot made of gold, silver or clay and be kept in secret and protected place.

This oil is praised by lord Dhanwanthari. It should be prepared for kings, other influential persons like kings, delicate, cheerful and wealthy persons.

बला तैल के गुण या प्रयोग (Action and uses of bala tūila)

इसे पान, नाचन, अभ्यङ्ग एवं बस्ति के रूप में प्रयोग करना चाहिए।

सूतिका स्त्री को बलानुसार पीने को देना चाहिए, जो स्त्री गर्भ को इच्छा रखने वाली हो (बन्ध्या हो), पुरुष क्षीण शुक्रवाला हो, वात-क्षीण, मर्महृत, मर्धित (कुचले हुए), अभिहत (चोट खाए हुए), भग्न (अस्थि टूटे हुए) तथा श्रम से थके हुए आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए हितकारी है। आक्षेपक आदि वात-व्याधियों में लाभकारी है, हिकका, कास, अभिमन्थ, गुल्म तथा अति कठिन श्वास में लाभकर है। षड्मास तक प्रयोग करने के पश्चात् आनवृद्धि ठीक हो जाती है, पुरुष की धातुओं की वृद्धि होती है तथा उसका जीवन स्थिर हो जाता है^१।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी शब्दभेद से लिखा है कि राजा, राजा-सदृश पुरुष, कुश, सूतिका, शिशु, वृद्ध, सुकुमार, शूल पीड़ित महाग्रहों से आक्रान्त, दीर्घकालीन या जीर्ण रोग से पीड़ित, मर्म-विद्ध, पीत, अभिहत, भग्न, विरहितव्याग, दैवप्रकाय तथा मानसिक-चर से पीड़ित व्यक्तियों को पान, नस्त, अभ्यङ्ग, तथा बस्ति के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग

नोट - सन्दर्भ पृष्ठ ५३६ में देखें

से बल, पौष्ट, स्मृति, मेधा, अग्नि, वीर्य तथा ओज को वृद्धि होती है। पक्षाघात, अक्षेपक तथा अर्द्धि आदि विविध वात-विकार, गुल्म, हिक्का, श्वास तथा कास का निवारण होता है। नित्यप्रति प्रयोग करने से छह मास में आन्त्रवृद्धि का शमन एवं बन्ध्या स्त्री को इच्छानुकूल गुणवान् पुत्र मिलता है^१।

अष्टाङ्गहृदय में संक्षेप में लिखा है कि सूतिका, बाल, ममस्थि-क्षत, क्षीण व्यक्तियों द्वारा यह पूज्य है। ज्वर, गुल्म, ग्रह-बाधा, उन्माद, मूत्राघात तथा आन्त्रवृद्धि को ठीक करता है। यमिरीयों तथा क्षय का नाश करता है^२।

महर्षि शार्ङ्गधर मतानुसार यह तैल गर्भच्छुक्क (गर्भ की इच्छा रखने वाली स्त्री) क्षीण-तप्तस्य पुरुष, व्यायाम से क्षीण-मूर्खी, सूतिका तथा राजाशयों के योग्य प्रशस्त तैल है। सभी प्रकार के वात-विकारों को यह बलतैल दूर करता है^३।

१. बलामूलकषायस्य दशमूलकृतस्य च ॥ २९॥

यवकोलकुलस्थानो बन्धस्य पयसस्तथा। अष्टावधौ शुभा भागसौतैलकस्तैलकः ॥ ३०॥
पचेदावपि मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम्। तथाऽगुं सज्जसं सत्तं देवदारु च ॥ ३१॥
मज्जिषां चन्दनं कुशमेतौ कालानुसर्गिणाम्। मांसी शैलेयकं परं तगरं शार्ङ्गिणं ब्रह्माम् ॥ ३२॥
शालावीमक्षान्नां शतपुष्पां पुनर्नवाम्। तत् साधुसिद्धं सौवर्णं राजते मृन्मयेऽपि वा ॥ ३३॥
प्रक्षिप्य कलशे साम्यं स्वन्मृगं निषापदेत्। बलतैलमिदं छानं सर्वव्याधिकारदत् ॥ ३४॥
यथावत्तमते मात्रां सूतिकायै प्रदापदेत्। या च गर्भाधिनी नारी क्षीणपुरुषश्च यः पुमान् ॥ ३५॥
वातक्षीणे मर्महते मथितेऽभिहते तथा। भनो भ्रमापफले च सर्वशैवोपयुज्यते ॥ ३६॥
एतदक्षेपकादीन् वै बालव्याधीनामोहति। हिक्कां कासमधीमन्मं गुल्मं क्षयं च दुस्तपम् ॥ ३७॥
पण्मासगुण्युन्मत्तान्त्रवृद्धिमोहति। प्रत्यग्रागुः पुरुषो भवेच्च स्थिरयौवने ॥ ३८॥
राशोमेदिह कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः। सुविनः सुकुमारश्च धनिश्चापि ये नराः ॥ (सु० सं० चि० १५/२९ से ३९)

२. स्नेहचतुर्थीशो भेषजकल्कः ॥ (सु० सं० चि० १५/३० को डल्हण टीका)

३. अथबलतैलमुपदेष्टव्यम्:- बलामूलकषायस्य भागाः षट् तावत् एव पयसे यवकोलकुलस्थदशमूलकषायस्य भागो भागश्चतुर्दश-स्तेतस्य तत्सर्वमैकत्र्यं कृत्वा शलशचूर्णानि चावाप्य काकोलीक्षीकाकोलीजीवकर्मभक्तमुद्रपुष्पाभाषपर्णमिन्दामहामेदाक्षीर-शुक्रालम्बुकन्दवल्गुमज्जिषाचन्दनसारिवालतालगाकुशशतवर्धक्षान्वागुनर्नवपुष्पाभाषातपससस्तैलयेतलवाचागुलकालानुसर्ग-सैन्धवानि शर्मर्मुद्रिणि साधयत्वा सुभाजनेऽगुणं निदध्यात्। एष भावलोष्यन्तरेऽभिमततैलाजो राजा राजमात्राणां कुशानां सूतिकाणां शिशुनामलोक्यसोऽसु कुमाराणां शूलीनां महाराष्ट्रहृदिनां दीर्घयोगक्षपितवपुषा ममीन्द्रपतिनाभिहतभग्नविश्लब्धज्ज्ञानां दैवोपघाताभिशस्तमनोऽव्यपरीतानां पाननाकान्ध्रवृद्धिरितु प्रयोच्यः। तेन बलपौष्टस्यमृतिमितिमेधागिन्नीयौजांसि वर्धन्ते पक्ष्यातक्षेपकादितादिविविधवातविकारगुल्महिष्माश्वसकासा निवर्तन्ते। अहर्हश्चाप्युज्यमानेन षण्मासादान्वृद्धिः प्रशामेति। बन्ध्या च पुनं गुणवन्तिमिच्छ्या तप्तत इति ॥ (अ० सं० शा० ४५/१)

४. बलामूलकषायस्य भागाः षट् पयसस्तथा। यवकोलकुलस्थानां दशमूलस्य चैकतः ॥ ४७॥

निम्बकाश्रभाणो भागश्च तैलस्य तु चतुर्दशः। द्विमेदातममज्जिषाकाकोलीद्वयचन्दनैः ॥ ४८॥

सारिवाकुशगारजीवकर्मभक्तैः। कालानुसर्गशैलेयब्रह्मामुनर्नवैः ॥ ४९॥

अक्षान्वाघावीक्षीरशुक्रागुण्डीनारासैः। शालाशूषपुष्पांस्तैलाज्यकर्मैः ॥ ५०॥

पक्कं मुद्रिणा तैलं सर्ववातविकारिणम्। सूतिकाबालममस्थिक्षतक्षीणेषु पुनितम् ॥ ५१॥

ज्वरगुल्मग्रहेण्मादमूत्राघातान्वृद्धिजित्। धन्तरेऽपिभनं योनिरोगक्षयपहम् ॥ ५२॥ (अ० ह० शा० २)

५. बलामूलकषायेण दशमूल शूतेन च। कुलस्थयवकोलानां क्वाथेन पयसा तथा ॥ १११॥

अष्टाष्टभाग्युक्तेन भागमेकं च तैलकम्। गणेन जीवनीयेन शतवर्धेन्द्रारुणम् ॥ ११५॥

मज्जिषाकुशशैलेयगारुसैन्धवैः। वचापुनर्नवामांसासिर्वाद्यपपत्रकैः ॥ ११६॥

शतपुष्पाऽश्रांभाध्यानेनया च विषयश्चेत्। गर्भाधिनीनां नारीणां नराणां क्षीणैरेसाम् ॥ ११७॥

व्यायामक्षीणराजाणां सूतिकाणां च युज्यते। राजयोगमिदं तैलं सुखिनां च विशेषतः।

बलतैलमितिच्छानं सर्ववातमयापहम् ॥ ११८॥ (शा० सं० मध्य० ९)

The oil should be used orally, inhaled, massaged and also as an enema, it should be given orally to a puerperal woman; be used by the woman desirous of having a conception (infertile woman), the man suffering from loss or deficiency of *śukra* (frigidity and infertility), others (both sexes) having *vātakṣaya*, injuries to the *marmas* (vital parts), crush injury, other trauma, fracture of bone, dislocations of joints, injury due to fall, or who are tired due to excessive exercise. It can also be used by emaciated persons, puerperal woman, children, old persons, persons seized with *grahas*, suffering either from chronic diseases or for a long period, having colic, psychological fever (*māṁśāṅkavāra*) or *daiwaprakopa* (causes of good). It is also beneficial in convulsive disorders, paralysis, facial paralysis and other disorders of *vāta*, *hikkā* (hiccup), *kāsa* (cough), *adhimantha* (nemicrania), *gūlma* and severe *śwāsa* (dyspnoea). Its continuous use for six months cures *āntravṛddhi* (hernia), increases *dhātus*, retains youth and gives a woman desired son. It also increases strength, virility, memory, intellect, *agni* (digestive/metabolic power), *vīrya* and *ojas*. It also cures fever, *unmāda* (insanity), *mūirvāghāta* (suppression/retention of urine), *yonivyāpat* (gynec disorders) and *kṣaya* (tuberculosis).

२) शतपत्रक बलतैल (Śatapatraka bala-taila)

बला कषाय को अनेकों बार लिए हुए (बलाकषाय में अनेकों बार भिगा कर सुखाए हुए) तिलों का तैल निकालकर, उसे बला-क्वाथ के हो साथ सौ बार पाक करे। इस तैल का वायु रहित एकल पर में बलानुसार सेवन करे। तैल के जीर्ण हो जाने पर दूध के साथ षष्टिक आदि अन्नों का ओदन स्निग्ध करके (घृत मिलकर) भोजन करे। तैल को एक द्रोण मात्रा का इस प्रकार सेवन करने से मनुष्य समय पर (भोजन के समय) दुग्धा आहार करता है, बल एवं वर्ण से युक्त, सभी पापों से विमुक्त तथा शतायु हो जाता है। एक एक द्रोण तैल सेवन से सौ-सौ वर्ष की आयु की वृद्धि होती है^१। टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि कुछ आचार्यों ने बला कषाय के साथ बला-कल्क का तथा अन्य पूर्ववर्णित बलतैल में प्रयुक्त प्रक्षेप द्रव्यों के प्रयोग का विधान बताया है^२।

The oil extracted from *tillas*, which have already been soaked several times in the decoction of *bala* should be cooked with decoction of *bala* repeatedly for hundred times. This should be taken orally in secluded or peaceful place according to one's own strength. By using this oil in the quantity of one *droṇa* the individual consumes double diet, attains strength and complexion, gets rid of all the sins and survives for hundred years. Consumption of each *droṇa* of oil increases the life by hundred years (by consuming two *droṇa* one will live for two hundred years etc.). Dailhana has quoted the opinion of others that while preparing the oil paste of *bala* and other drugs enumerated under *bala taila* should also be added in this.

१. बलाकषायपीठ्यस्तेष्वो वायमेकशः। तैलमुसाद्य तत्त्राधशपत्रककृतं शुभम् ॥ ४०॥

निबाले निपुलागरे प्रयुञ्जीत यथावत्। जीर्णैर्मिन् पयसा स्निग्धयस्त्रीयात् षष्टिकौटमम् ॥ ४१॥

अनेन विधिना द्रोणमुपयुज्यन्ममोत्तमम्। भुञ्जीत द्विगुणं कालं बलवर्णाचितस्ततः ॥ ४२॥

सर्वभयविनिर्मुक्तः शतायुः पुरषो भवेत्। शतं शतं तयोक्तयो द्रोणे द्रोणे प्रकीर्तितः ॥ ४३॥ (सु० सं० चि० १५)

२. तत्त्राधं तत्कल्कमेव केतयेकं, पूर्वबलतैलसमुद्दिष्टैर्मधुआदिकल्कैरेवचन्ये ॥ (सु० सं० चि० १५/४० को डल्हण टीका)

३) अतिबल, गुडूचि आदि से निर्मित तैल (The oils prepared with atibala and guduchi etc. other drugs)

बुद्धिमान वैद्य बलतैल की ही भाँति अतिबल, गुडूचि, आदित्यपर्णी, सैर्यक, वीतर, शलावरी, त्रिकपटक, मधुघृष्टी तथा प्रसारीणी से (सभी द्रव्यों से पृथक् पृथक्) तैल का पाक करे। (अथवा) नीलोलप तथा शलावरी मूल को गोदुग्ध में पाक करे, इस सिद्ध दुग्ध के साथ ही बलतैल में प्रयुक्त कल्क द्रव्यों को डालकर सौ बार तिल तैल का पाक करे। उपर्युक्त सभी तैलों का उपयोग विशेषकर उनके गुण बलतैल के ही सदृश समझने चाहिए। टीकाकार डल्हण ने वीतर से स्वनाम प्रसिद्ध वीतर, अर्जुन या कोकिलाक्ष ग्रहण करने का अन्य आचार्यों के मत का उल्लेख किया है तथा अतिबल आदि तैलों को, जहाँ उन्हीं द्रव्यों के बजाय एवं कल्क से पाचन करने का विधान लिखा है।

Just like *bala itaila* wise physician should prepare the oils with any one out of *atibala*, *guduchi*, *adityaparni*, *sairiyaka*, *viratara*, *salawari*, *trikapatka*, *madhughasti* and *prasariini* etc. drugs, or else he should cook the cow's milk with *nilotpala* and root of *salawari* then add paste of all the drugs described under *bala itaila*, and cook the *tila* oil with this mixture repeatedly for hundred times. The action and uses specially beneficial effects of all these oils are similar to *bala itaila*. While preparing the oils, decoctions and pastes of respective drugs should be used.

मूढगर्भ में उदर-विपाटन (Laparotomy or cesarean section for extracting mūdhagarbha)

वरसमाविपत्रायाः कुक्षिः प्रसन्दते यदि । तत्क्षणाजन्मकाले तं पाटयित्वोद्धरेद् भिषक् ॥ १४॥
(सु० सं० नि० ८/१४)

वरसमाविपत्रायाः कुक्षिः प्रसन्दते यदि । तत्क्षणाजन्मकाले तं पाटयित्वोद्धरेद् भिषक् ॥ १४॥
(सु० सं० नि० ८/१४)

बरसिद्धरे विपत्रायाः कुक्षिः प्रसन्दते यदि । जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वोद्धरेच्छुम् ॥
(अ० सं० शा० ४/५२, अ० ह० शा० २/५३)

मारे जाते हुए बकरे के समान मृत स्त्री को कुक्षि यदि प्रसन्दन करती हो तो जन्मकाल में तुलत ही पाटन (कुक्षि का) करके शिशु का आहरण कर लेना चाहिए। टीकाकार डल्हण ने स्पष्टीकरण में लिखा है कि यह वर्णन माता की मृत्यु हो जाने के बाद जीवित गर्भ के अपकषण के लिए है जिस प्रकार ग्रीवा-मोदन करने से बकरा अतिशीघ्र ही बिना कष्ट के मर जाता है उसी प्रकार मृत्यु हुई स्त्री के लिए यह विधान है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार यांत्रिक श्वासवरोध करके बकरे को मार देते हैं उसी प्रकार (आकस्मिक रूप से) मृत स्त्री के लिए यह विधि वर्णित है उस स्त्री

१. बलकल्पेनातिबला गुडूच्यदित्यपर्णिषु । सैर्यके वीतर शलावरी त्रिकपटके ॥ ४४॥
तैलानि मधुके कुर्वात् प्रसारण्याश्च बुद्धिमान् । नीलोलपतं वरीमूलं गव्ये क्षीरे विपाचयेत् ॥ ४५॥

शलापकं ततस्तेन तिलतैलं पचेद् भिषक् । बलतैलस्य कल्कांसु सुषिष्टान्तरं चापयेत् ॥ ४६॥

सर्वेषामेव जानीयादुपयोगो विकितसकः । बलतैलवदेतथा गुणांश्चैव विशेषतः ॥ ४७॥ (सु० सं० नि० १५)

२. वीतरः स्वनामप्रसिद्धः, अर्जुन इत्येके, कोकिलाक्ष इत्यपरे । अतिबलादितैलेषु च बलतैलौक्तिककल्कप्रक्षेपः,
अथवाऽतिबलादीनमेव क्वाथकल्काभ्यां तैलानि पक्वयानीति ॥ (सु० सं० नि० १५/४४ व ४६ की डल्हण टीका)

३. मातुर्गर्भाया अपि जीवितो गर्भस्य अपकर्षणं स्वयंवाह-वसमोरेत्यादि । वस्तुमात्रशलावलवममपम् । एतेन ग्रीवामोदनेन आशुतमं अकिल्ब मरणमुक्तं, तेन विपत्रायाः मूलायाः स्थिर इत्यर्थः । अयमभिप्रायः-यथा वस्तं निरुद्ध्वासं कृत्वा यांत्रिकान् मारयन्ति एवं या मूल तस्या इत्यर्थः । तत्क्षणात् शटिकाद्वयमप्ये, परतस्तु गर्भोऽपि प्रितरे इति भावः । अन्ये तत्क्षणादित्यत्र मुहूर्तमिति पठन्ति, तत्रापि स एवार्थः । जन्मकाले नवमममसादिकाले इत्यर्थः । तं गर्भं । पाटयित्वा स्त्रीकुक्षिं विदार्य ।
(सु० सं० नि० ८/१४ की डल्हण टीका)

में उसी क्षण या दो घटी के मध्य में या मुहूर्त मात्र में ही क्रिया करनी चाहिए अन्यथा गर्भ भी मृत हो जाएगा। जन्मकाल से तात्पर्य नवम मास से है। उस गर्भ को स्त्री को कुक्षि का विदारण करके प्रसव कराना चाहिए (चि० ३०)।

उपर्युक्त वर्णन का सारांश यह है कि गर्भ की पूर्णवस्था के काल में यदि किसी आकस्मिक कारण से स्त्री की मृत्यु हो जाय तथा कुक्षि में स्पन्दन हो रहा हो तो उसी क्षण कुक्षि का विपाटन करके गर्भ का आहरण कर लेना चाहिए, विलम्ब करने से गर्भ-मृत्यु का भय रहता है। इस आशय का स्पष्ट निर्देश बह्मसेन में मिलता है कि जब जन्मकाल को प्राप्त

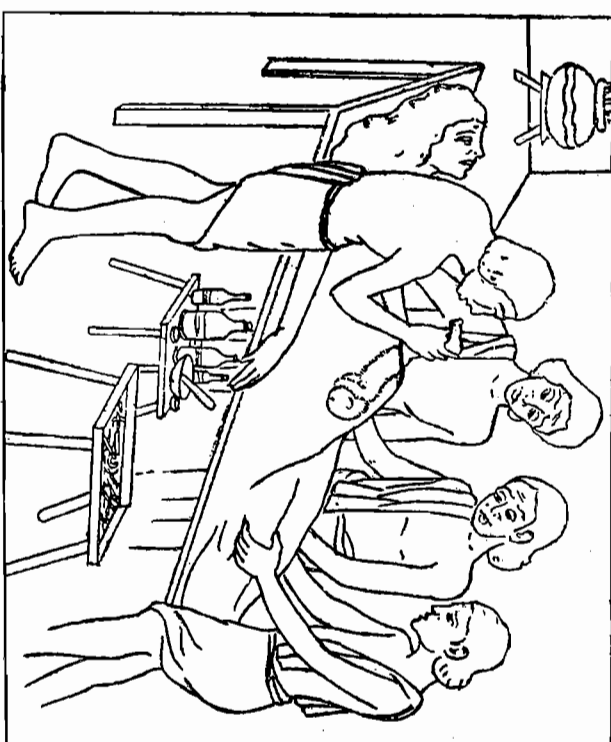


Fig. (30) : Laparotomy for extracting the fetus or cesarean section.

गर्भ-युक्त गर्भिणी स्त्री को अभिषाल से मृत्यु हो जाय परन्तु उसका गर्भ प्रसन्दन करता हो (गर्भ-हृदयानि उपस्थित हो) तो उस गर्भ का तत्क्षण ही पाटन (उदर का) करके आहरण कर लेना चाहिए।

वाग्भट-द्वय ने लिखा है कि यदि मृत स्त्री की कुक्षि बरसिद्ध में (या बरसिद्ध के पास) स्पन्दन करती हो तो जन्मकाल में (गर्भ की पूर्णवस्था हो तो) शीघ्र ही विपाटन करके शिशु का उद्धरण कर लेना चाहिए। टीकाकार इन्दु ने बरसिद्ध को विपाटन करके शिशु के आहरण करने का निर्देश दिया है। पाटभेद में महर्षि सुश्रुत ने भी 'बरसिद्ध' शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकार अरुणदत्त ने भी गर्भ-प्रसवोन्मुख-काल (प्रसव की प्रथमावस्था या आसन्नप्रसव) में मृत गर्भिणी के बरसिद्ध के पास अत्यन्त चालित कुक्षि होने पर कुशल वैद्य द्वारा कुक्षि-प्रसन्दनों के अनन्तराल में कुक्षि

१. अभिषालाभूतायास्तु गर्भः प्रसन्दते यदि । जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वोद्धरेच्छुम् ॥ १११॥ (वह्मसेन ३८/१११)

२. गर्भस्य जन्मकाले जीवितो यदि माता विपत्रा स्याततः कुक्षिप्रसन्दनेन जीवन्तं गर्भं विदित्वा ततो बरसिद्धौ विपाट्य तमुद्धरेत् ॥ (अ० सं० शा० ४/५२ की इन्दु टीका)

३. बरसिद्धरे विपत्राया इति पाटनान्तम् ॥ (सु० सं० नि० ८/१४ कलकला प्र० की पाटयिपर्णी में उद्धृत)

का पाटन कर बालक के उद्धरित कर लेने का वर्णन दिया है।^१

In a woman who has died during labour just like a killed goat (*vastamāra*) if quivering of abdomen still persists, the abdomen should immediately be opened and fetus extracted. Dahana has explained this verse that the procedure is to be done in ninth month (full term) of pregnancy and in a woman who has died accidentally all of sudden in the same way as a goat throttled or sacrificed by priest dies suddenly without much trouble; in such case immediately within two *ghaṭīes* or one *mūhūrta* (fortyeight minutes) the fetus should be extracted by laparotomy (fig. 30) or else the fetus will die. In Vaṅgassena this Dahana's view is given in unequivocal words that when a woman carrying full term fetus dies due to trauma (sudden accidental death) but the quivering of fetus (fetal heart sounds) still persist, then the fetus should immediately be extracted by laparotomy.

Vāgbhata has mentioned that during *jannakāla* (delivery of full term fetus) if quivering of abdomen over *bastidwāra* (neck of bladder or suprapubic or bladder region) of dead woman is persistent then the fetus should immediately be delivered by laparotomy. Indian opines that the laparotomy should be performed over bladder region. In one edition of *Suśruta Samhitā* the word *bastidwāra* has been used in place of *vastamāra*, which will have similar explanation as that of Vāgbhata.

Arūṇadatta has explained that if the abdomen of woman dieing during first stage of labour excessively quivers near the bladder-region, then the expert physician should perform the laparotomy during interval period of quiverings and extract the child.

विमर्श (Comments)

संहिताओं में विषय के वर्णनार्थ प्रारम्भ में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं 'वसमार' एवं 'बस्तिद्वार'। 'बस्तिद्वार' शब्द से हिन्दी व्याख्याकारों ने दो अर्थ किए हैं बस्तिद्वार के पास स्मन्दन^२ अथवा बस्तिद्वार के पास आकर गर्भ का अवरोध होना^३। इन सभी व्याख्याओं को देखने से ऐसा अभ्यास होता है कि विद्वत् स्वयं ही इस वर्णन की युक्तिसंगतता या स्मयीकरण के लिए सन्देहास्पद थे। सुश्रुत की अन्य पाण्डुलिपि में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृत स्त्री की कुक्षि यदि स्मन्दन कर रही हो तो जन्मकाल में उसी क्षण ही पाटन (कुक्षि का) करके (गर्भ का) आहरण चिकित्सक को कर लेना चाहिए^४।

उपर्युक्त वर्णन से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं-

१) उदर-विपाटन करके परिपूर्ण गर्भावस्था अर्थात् नवम मास पूर्ण हुए गर्भ का ही आहरण करना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व के गर्भ को यदि आहत कर भी लिया जाय तो बाद में जीवित रहने की आशा कम ही रहती है।

२. विपश्चया:-मृताया गर्भिण्याः, यदि कुक्षिः प्रसन्दो-अपयन्तं चलति। क्व प्रदेष्टे? बस्तिद्वारे-तत्समीपे। कदा? जन्मकाले-गर्भप्रसवोमुखे काले। तदा कुशलो वैद्यः शीघ्रं (ततः -) कुक्षिप्रसन्दान्तरात्, पाटीयन्वा शिष्टं बालं उद्धरेत्॥

(अ० ह० शा० २/५३ की अरुण टीका)

३. अ० ह० शा० २/५३ की लालचन्द वैद्य कृत हिन्दी व्याख्या

३. अ० सं० शा० ४/५२ की आनन्देय गुप्त कृत हिन्दी व्याख्या

४. कुक्षिः प्रसन्दो यस्याः विपश्चयासमाहितः। तत्क्षणजन्मकाले तं पाटीयन्वाद्धरेत्क्षिप्य॥

(सं० संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पाण्डुलिपि संख्या ४४८१५)

२) कुक्षि या गर्भ का स्मन्दन गर्भ के जीवन का द्योतक है।

३) प्रसव की प्रथमावस्था में गर्भ-प्रेर या उदय होने वाला अङ्ग अधिकशः मिथ्या श्रोणिगुहा में ही रहता है अर्थात् नीचे नहीं जाता, बस्तिद्वार के पास स्फुरण भी इस तथ्य को ईंगित करता है। गर्भ के श्रोणिगुहा में अत्यधिक नीचे चले जाने पर गर्भ का उद्धरण कभी कभी अत्यधिक कठिन हो जाता है। प्रसव की प्रथमावस्था में गर्भिणी की मृत्यु होने (जो आर्वी का लक्षण है) का द्योतक है। गर्भाशय के संकोच को अवस्था में भी गर्भ का उद्धरण कठिन होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रसव की प्रथमावस्था में बस्तिद्वार में स्थित गर्भ को संकोच के अन्तर्गत में उद्धरण का निर्देश टीकाकार अरुणदत्त ने दिया है।

४) 'वसमार' तथा उसका इच्छा-कृत स्पष्टीकरण तथा वङ्गसेन का वर्णन कुछ अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है क्योंकि सामान्य रूप से अर्थात् किसी पूर्वकालिक व्याधि या मूढगर्भता के कारण यदि स्त्री की मृत्यु होगी तो उसका प्रभाव गर्भ पर भी पड़ेगा और उसकी भी जीवन-शक्ति क्षीण हो जायेगी अतः उद्धरण के पश्चात् भी वह जीवित रह सकने में असमर्थ होगा पर यदि किसी आतार्थिक कारण यथा शिरोभिघात या अन्य अभिघात से स्त्री की मृत्यु हो तो गर्भ पूर्ण स्वस्थ रहेगा एवं आहरण के पश्चात् जीवित रहने की सम्भावना अधिक होगी।

५) सामान्य रूप से माला की मृत्यु के बाद गर्भ भी श्वासवरोध से शीघ्र ही मृत हो जाता है अतः इस वर्णन की उपदेयता सन्देहास्पद हो जाती है फिर भी यह सम्भव है कि आकस्मिक दुर्घटना से मृत स्त्री का पूर्ण प्रगल्भ गर्भ यदि तत्क्षण निकाल लिया जाय तो वह जीवित रह जाय, क्योंकि माला की मृत्यु के लगभग १५ मिनट बाद भी उदर-विपाटन करके जीवित गर्भ के आहरण के उद्धरण मिलते हैं^५। अथवा गर्भ-युक्त गर्भिणी का दाह न कर दिया जाय इसलिए उसे बाहर निकाल लेना उचित है इस दृष्टिकोण से यह वर्णन दिया गया होगा।

In classics two words have appeared *vastamāra* and *bastidwāra*. The word *bastidwāra* has been explained in two ways by few commentators i. e. quivering near the bladder region or obstruction of fetus near the bladder region. This shows that relevance and explanation of this word is doubtful. Moreover in another *Suśruta Samhitā* this controversial description is replaced with a clear description that the fetus should be extracted immediately after death of the mother. Above description clarifies following points that—

i) Only ninth month or full term fetus should be delivered by laparotomy, because premature fetus even if delivered may not survive.

ii) Quivering of abdomen is indicative of alive fetus.

iii) During first stage of labour fetal head/presenting part remains high up or in false pelvis in majority of cases, it does not descend to pelvic cavity; quivering near bladder-region also indicates this very fact. Extraction of fetus after descent of presenting part in mid-cavity or below becomes very difficult. Death of woman during first stage of labour does not take place due to abnormality of labour, it is always due to some other cause. Excessive movement indicates too-much uterine contractions and relaxations; extraction of fetus during uterine contraction is difficult, considering these facts Arūṇadatta has advised extraction of fetus situated near urinary bladder, in first stage of labour during inter-contraction period.

१. मुनीं कर्तं ह्यत लिखित अर्धरेटिव आर्क्स्टेटिक्स (पृष्ठ १४२)

iv) Explanation given by Dalhana and description of Vanhasena is more logical, because if the woman dies due to other causes such as toxemia of pregnancy, very prolonged labour or any other complication, the disorder will have its impact on the fetus which may not survive even if delivered, however, when woman dies an accidental death the chances of survival of fetus may increase, because the fetus otherwise would be absolutely healthy.

v) Normally fetus dies immediately following death of the mother, hence the utility of this description becomes doubtful, however in rare instances one may deliver a living fetus by laparotomy even after a bit prolong time of woman's death. Munro Kerr in his operative obstetrics (page 142) has reported that in one instance an operation performed atleast fifteen minutes after the death of the mother resulted in the delivery of a healthy baby.

Besides, the extraction of fetus might also have been advised with the view that the dead woman may not be burnt with the fetus inside her abdomen because this practice is still existing.



अध्याय ९

CHAPTER IX

सूतिका-विज्ञानीय

(NORMAL AND ABNORMAL PUERPERIUM)

सूतिका की परिभाषा (Definition of *stūikā* or *puerperal woman*)

सभी आचार्यों ने अपरा-पतन के पश्चात् ही सूतिका-परिचर्या का वर्णन दिया है जिसका अन्तर्निहित अर्थ यह ही होता है कि अपरा-पतन के पूर्व स्त्री को सूतिका नहीं कहा जाना चाहिए। स्पष्टतः निर्देश महर्षि काश्यप ने किया है कि- (जालक का) प्रसव होने के बाद भी यदि अपरा न गिरे तो उसे प्रसूता नहीं कहा जा सकता अर्थात् अपरा गिरने के पश्चात् ही वह प्रसूता या सूतिका कही जानी चाहिए।

Though all the classics have advised specific management of *stūikā* (puerperal woman) only after expulsion of placenta, however, explicit description is given only by Kāśyapa. He says that after delivery of child till the placenta is not expelled, the woman can not be called *stūikā*, in other words *stūikā* term can be used only after expulsion of placenta.

सूतिकाकाल (Sūtīkākalā or duration of puerperium)

महर्षि चरक ने सूतिका-परिचर्या की किसी विशिष्ट अवधि का वर्णन नहीं किया जब कि अन्य आचार्यों ने एक निश्चित काल तक पथ्यादि व्यवस्था का विधान दिया है जो कि सूतिकाकाल की सीमा का निर्धारक है। वर्णन निम्न प्रकार है।

अनेनविधिनाऽध्वर्धमासमुपसंस्कृता विमुक्ताहाराचारा विगतसूतिकाभिधाना स्यात्, पुनरातवदर्शनादित्येके ॥

(सु० सं० शा० १०/१६)

एवं साऽध्वर्धमासमुपसंस्कृता क्रमेण विमुक्ताहारावहारयन्त्रणा विगतसूतिकाभिधाना स्यात्। पुनरातवदर्शनादित्येके ॥ (अ० सं० शा० ३/४९)

एवं च मासादध्वर्धमासमुपसंस्कृता विमुक्ताहाराचारा विगतसूतिकाभिधाना स्यात्पुनरातव दर्शनात् ॥

(अ० ह० शा० १/१००, १०१)

षड्भिर्मासैः प्रसूताया धातवो रुधिरादयः ॥ ५२ ॥

प्रत्यागच्छन्त्यसोमाया यथास्वं परिसंस्थितिम्।

एताव्यान्यव्य सञ्चिन्त्य विकित्तां संप्रयोजयेत् ॥ ५३ ॥ (का० सं० छि० ११)

इस प्रकार (सूतिकापरिचर्यान्तर्गत वर्णित विधि, आहार और आचार से) डेढ़ मास (४५ दिन) तक उपसंस्कृत (संस्कार या चिकित्सा की हुई) स्त्री विशिष्ट आहार एवं आचार (सूतिका के लिए निर्दिष्ट नियमों) तथा सूतिका नाम से सहित हो जाती है (अर्थात् ४५ दिन के बाद सूतिकावस्था समाप्त हो जाती है)। कुछ आचार्य पुनः आतव-दर्शन तक १. सूतायाश्चापि तत्र स्यादपरा केन निर्गता। प्रसूताऽपि न सूता स्त्री भवत्येवं गते सति ॥ (का० सं० छि० ११/६)

(सूतिकाकाल की अवधि) मानते हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि (वह स्त्री) इस प्रकार देढ़ मास तक उपसंस्कृत हो जाने के बाद तथा अन्य आचार्यों के मत से पुनर्जातव-दर्शन के बाद क्रमशः विशिष्ट आहार एवं विहार की यत्नणा तथा सूतिका-नाम से छिद्रित हो जाती है।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि इस प्रकार देढ़ मास या पुनर्जातव-दर्शन के पश्चात् स्त्री आहारादि के नियमों तथा सूतिका नाम से रहित हो जाती है।

महर्षि काश्यप के मतानुसार प्रसूता स्त्री के रोप-रहित होने पर उसकी रक्त आदि धातुयें षड् मास में अपनी पूर्व (गर्भावस्था के भी पूर्व की) स्थिति में आ जाती हैं इसका विचार करके ही विकिरसा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए (अर्थात् सूतिका काल ६ मास का होता है)।

भावप्रकाश^१ तथा योगरत्नाकर^२ में लिखा है कि प्रसूता स्त्री देढ़ मास के पश्चात् अथवा पुनः अर्तव-दर्शन के बाद सूतिका नाम से रहित हो जाती है ऐसा ध्वन्यन्तरि का मत है। उपद्रवों के समाप्त हो जाने पर तथा दोषों के शान्त हो जाने पर स्त्री चार मास के पश्चात् परिहारों (विशिष्ट आहार एवं आचार) का परित्याग कर दे।

काश्यप संहिता, भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर में सूतिका की विशिष्ट पथ्य-व्यवस्था एक मास के लिए वर्णित है परन्तु यह वर्णन सूतिका के विशिष्ट पथ्य का द्योतक है उसके काल का नहीं।

महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट्ट द्वय ने मूढगर्भ-शाल्योद्धारण के पश्चात् चार मास तक पथ्य व्यवस्था करने का निर्देश दिया है^३।

Caraka has not given any specific duration, however, all other classics have given definite period of specific dietetics etc. management for a puerperal woman, which can be considered as normal duration of puerperium.

Suśruta and both the Vāgbhāṭas have said that after 1½ month of regulated or restricted specific dietetics and mode of life the woman becomes free from the epithet of *sūtikā* and have cited the opinion of others that the woman should be called *sūtikā* till she does not restart her menstrual cycle; however after extraction of fetus in obstructed labour four month period for dietetic management is prescribed. Though Kāṣyapa, Bhāva-prakāśa and Yōgaratnākāra have given the duration of specific dietetic management only for one month, yet Kāṣyapa has mentioned the duration of *sūtikākāla* as six months and Bhāva-prakāśa etc. besides agreeing with the description of Suśruta (i.e. 1½ month) have mentioned that after subsidence of complications and aggrava-tion of *doṣas* (caused during labour due to *dhātukṣaya*) the woman should give up specific mode of life after four months.

१. प्रसूता सार्धमासतो दूधे वा पुनर्जाते । सूतिका नामहीना स्यादिति ध्वन्यन्तरेर्मम ॥
व्युपद्रवा विमुक्तां च विश्राय वरवर्णिनीम् । ऊर्ध्वं चतुर्थ्यां मासेभ्यो नियमं परिहारयेत् ॥ (भा० प्र० पूर्व ४५, ६)
प्रसूता मतम् ॥ १६६ ॥
उपद्रवविमुक्ताश्च मासेभ्यः परिहारं विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥ (उपसृक्त सदृश ही) (भा० प्र० चि० ७०/१६६, १६७)
२. प्रसूता विसर्जयेत् ॥ (भा० प्र० चि० ७० सदृश ही) (यो० २० स्त्रीरोग चि०)
३. का० सं० चि० ११/२७, भा० प्र० चि० ७०/१६५ तथा यो० २० स्त्रीरोग चि० (समाप्त परिचर्यान्तर्गत वर्णित)
४. सु० सं० चि० १५/२८; अ० सं० शा० ४/५०; अ० ह० शा० २/४६ (पृष्ठ ५३१, ५३२)

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णित विषय का समष्टि रूप में अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सूतिकाकाल की अवधि के बारे में आचार्यों ने चार सीमायें रखी हैं। ४५ दिन, पुनः रजोदर्शन तक, चार मास तथा षट्मास। गर्भावस्था में प्रजननसंस्थान के रचनात्मक घटकों में परिवर्तन होते हैं जो सामान्यतया प्रसव के बाद ६ सप्ताह या देढ़ मास के अन्तर अपनी गर्भावस्था-पूर्व की स्थिति में पुनः पहुँच जाते हैं, परन्तु डिम्बग्रन्थि के रसों के निर्माण को पुनः अपनी पूर्व-स्थिति में आने में अत्यधिक व्याकणत वैभिन्य दृष्टिगोचर होता है यथा कुछ स्त्रियाँ प्रसव के पश्चात् दूसरे मास से ही रजःस्वला होने लगती हैं एवं कुछ वर्षों तक भी अनार्तवा रहती हैं, सम्भवतः इसी वैभिन्य के कारण आचार्यों ने पुनः रजोदर्शन ही लिखा है कोई निश्चित काल नहीं दिया, अर्थात् देढ़ मास के काल का वर्णन रचनात्मक घटकों की दृष्टि से है जब कि पुनः रजोदर्शन डिम्बग्रन्थि एवं गर्भाशयतन्त्रिका के गर्भावस्था-पूर्व सदृश सामान्य क्रिया का द्योतक है। षड् मास की सीमा सम्भवतः रजोदर्शन की उपस्थिति एवं चार मास की सीमा मूढगर्भादि या अन्य उपद्रव-युक्त प्रसव की पथ्य-व्यवस्था को दृष्टिगोचर रख कर दी गई है।

Considering above description collectively, four specific durations of *sūtikā* emerge out i.e. 1½ months, reappearance of menstruation, six months and four months.

Anatomic changes occurring in reproductive organs during pregnancy reach their almost pre-pregnancy stage after about six weeks, however, in resumption of pre-pregnancy physiology i.e. ovarian and menstrual cycle great individual variations occur, as some get it even for one or two years. Considering this individual variation, the authors have not given any specific time limit, rather have just said that 'reappearance of menstruation', In other words it can be said that 1½ months duration and reappearance of menstruation is given considering anatomical and physiological changes of reproductive system respectively. The limit of six month probably reflects the idea about reappearance of menstrual cycle, while four months period is probably given keeping in view the *mūḍhagarbha* or other abnormal labours, where-in post-operative management for four months has been advised.

प्रसवोपरान्त पुनः रजोदर्शन-हेतु (Factors responsible for reappearance of menstruation after delivery)

तथैव गर्भः सूतायः (शु० पा० गर्भसूताया) सद्यः सत्याय कल्पते ।
शेषं तु रुधिरभूतं कारं योनिं च समीति ॥
धातुषु प्रतिपूर्णेषु शरीरे समवास्थिते । संचितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन मुञ्चति ॥

(का० सं० चि० १/२१, १२)

उसी प्रकार (जिस प्रकार गर्भिणी का आहार-रस गर्भ, स्तन एवं स्वरशरीर का पोषण एवं वर्धन करता है) गर्भ के प्रसव हो जाने के बाद (माता के आहार-रस से) तत्काल ही सत्य की उत्पत्ति होती है। शेष (रस) शरीर के रूप में होकर शरीर एवं योनि में जाता है। धातुओं के प्रतिपूर्ण हो जाने तथा शरीर के समवास्थित हो जाने पर यही योनि में सञ्चित रक्त समय पर मुञ्चित होता है।

After delivery the *dāra-rasa* reaches the breasts and immediately forms the milk, remaining *rasa* getting transformed into the blood circulating in whole body reaches the *yoni* (reproductive system). After attainment of replenishment of *dhātus* and steadiness of body, the blood accumulated in *yoni* (uterus) is discharged periodically.

विद्यार्थ (Comments)

महर्षि काश्यप ने सूतिका को पुनःप्रजोदधन के लिए तीन जातों का महत्त्व दिया है। धातुओं की प्रतिपूर्णा, शरीर का स्थिर या दृढ़ होना तथा योनि में रक्त का सञ्चय।

अ) धातु-प्रतिपूर्णातः—शरीर को सतधातुओं का अर्थात् रस से शुष्क पर्वत धातुओं का प्रातिपूर्णा होना। प्रसवोपातल कामो कभी अत्याधिक रक्तस्रावादि होने पर उत्पन्न पाण्डु से रजोदर्शन प्रारम्भ होने में विलम्ब होता है। धातु शुष्क तथा उपधातु क्रमशः पीयूषग्रन्थि तथा टिक्टग्रन्थि के स्रावों के रूप में पूर्व-वर्णित है जिनका सामान्य होना पुनः रजोदर्शन के लिए अत्यावश्यक है।

अ) शरीर का व्यवस्थित होना—यह शरीर के स्थिर, दृढ़ या रोग रहित होने का ध्योतक है। शरीर की विभिन्न व्याधियाँ अग्रप्रत्यक्षतया बाहुओं को प्रभावित कर रजोदर्शन को प्रभावित करती हैं, साथ ही स्त्री की मानसिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ सकता है। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्त्री के स्थिर, दृढ़ एवं स्वस्थ होने पर ही प्रसवोपरान्त रजोदर्शन प्रारम्भ होता है।

इ) योनि मे रक्त का सञ्चय-योनि अथवा गर्भाशय की धमनियों में सम्पूर्ण मास तक सञ्चित रक्त ही ऋतुस्राव के समय बाहर निकलता है । शरीर स्वस्थ होने एवं धातुओं के सामान्य होने के बाद भी यदि गर्भाशयाब्ज:कला में (प्रसवोपरान्त तीव्र उपसर्गादि जन्य) विकार आ जाय तो रक्त का सामान्य सञ्चय नहीं हो पाएगा एवं रजोदर्शन नहीं होगा अतः योनि या गर्भाशय में रक्त का सञ्चय रजोदर्शन के लिए आवश्यक है ।

Three factors have been emphasized i.e. replenishment of *dhātus*, steadiness of body and accumulation of blood in *yoni* (uterus). The explanation of each one is given here—under—

a) **Replenishment of dhātus**—This indicates replenishment of all the seven *dhātus* i.e. from *rasa* to *śūkṛa*. Sometimes in anaemia caused either due to excessive postpartum haemorrhage or due to certain other causes the onset of menstruation after delivery may be delayed. *Śūkṛa* the seventh *dhātu* and *ārtava* an *upadhātu* refer to anterior pituitary and ovarian hormones respectively. Proper presence of these is indispensable for onset of menstruation.

b) **Steadiness of body**—Here this steadiness refers to healthy state of body. Certain diseases may influence the formation of proper *dhatu*s thus the menstruation. Psychology of woman also plays an important role in menstrual physiology. Only after proper physical and psychological health the woman restarts her menstruation.

c) *Accumulation of blood in yoni or uterus*—The blood collected in uterus for whole month within its *dharmānīs* is discharged during menstruation. Inspite of proper physical and mental health, if endometrium is diseased (due to acute puerperal infection etc.) the blood will not get accumulated and menstruation will not restart.

सूतिका-परिचर्या (Management of puerperal woman)

अ) सूतिका के लिए मणि (Amulet for puerperal woman)

प्रजाता स्त्री को त्रिवृत् को मणि बनाकर शिर में धारण करनी चाहिए ।

The puerperal woman should tie amulet of *irivir* over the head.

१. त्रैवृत्तं तु मणिं कृत्वा तं श्रोण्यां गभिर्णा सदा । प्रजाता शिरसा राजन् धारयेत्॥ (का० सं० छि० १०/१८९)

सूक्ति-विज्ञानीय

୧୧୪

आ) सामान्य परिचर्या (General care i.e. mode of life and diet)

सूक्तिकां तु खलु बभूषीकतां विदित्वा स्नेहं पाययेत् प्रथमा शक्या सपिंसैलं वसं मज्जानं वा सात्थ्यीभावमभिसमीरय पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्याचित्रकशूद्रबेरचूर्णसहितम् । स्नेहं पीतलस्याश्च सपिंसितौलाभ्यामप्यव्य वेष्टयेदुदरं महाताड्येन वाससा; तथा तस्या न वायुरन्तरे विकृतिमुदायत्यनवकाशात्वात् । जीर्णं तु स्नेहे पिप्पल्यादिभिरेव सिद्धां यवापूं सुक्लिधां द्रवां मात्रशः पाययेत् । उभयतः कालं चोष्णोदकेन च परिषेचयेत् प्राक् स्नेहयवागुपानाभ्याम् । एवं पञ्चरात्रं समात्रं वाजुत्पाल क्रमेणग्याययेत् । नस्त्यवृत्तमेतावत् सूक्तिकायाः ॥

(च० सं श० ८/४८)

अथ सूतिकां बलतैवाप्यत्कां वातहौषधनिष्क्रान्थेनोपचरेत् । सरोषदाषां तु तदहः पिपपलीपिपपलीमूल-
हसिनापिपपलीविचक्रभृङ्गवेचर्या गुडोदकेनोष्णेन पापयेत् एवं क्षिरात्रं क्षिरात्रं वा कुयदादुदुष्टोपिनात् । विशुद्धे ततो
विदापिगन्धादिसिद्धां स्नेहयवान् वा पापयेत् क्षिरात् । ततो यवकोलकुलत्थसिद्धेन नाङ्गलसेन शाक्योदनं
भोजयेद्बलमनिवत्तं वा वेक्ष्य ॥ १६ ॥

प्रायश्चिन्नाप्रभृतौतोष्णोदकेन परिषिञ्चेत् । क्रोधायागमसैश्वर्यादीन् परिहरेत् ॥ १८॥ (सु० सं० श्रा० १०/१६, १८)

अथ सूतिकां बलातैरेताभ्यन्यात् । बुधुक्षितां च पञ्चकोलचूर्णेन यवान्पुक्कुञ्चिकावव्याचित्रकालोष-
सैश्वर्यचूर्णेन वा युक्तामहःपरिणामिनीं यथासात्त्वं स्नेहमात्रां पाययेत् । स्नेहायोग्यां वातहारीषधव्याशं
ह्रस्वपञ्चमूलव्याशं वा पीतवत्याश्र यमकेनभ्यन्य चेष्वेवोदुदं वस्त्रेण । तथा न वायुर्भद्रविक्रितिमुत्पादयेद-
नवकाशत्वात् । जीर्णे तु स्नेहे पूर्वैषैरैव मिश्रं विद्यादिगणव्याशेन क्षीरिण वा यवागूं सुचित्रां द्रवां मात्रया
पाययेत् । प्राक्स्नेहयवागूपात्राभ्यां चोभयकालमुष्णोदकेन परिषेचयेत् ॥

एवं त्रिरात्रं पञ्चरात्रं सप्तरात्रं चाऽनुप्राप्य ततो यवकोतकुलस्थयूषेण लघुना चान्नपानेन द्वादशरात्रात्परं जाह्नलसामिदिभश्च क्रमादाप्रायेदीनिबलदादीत्यपेक्ष्य । क्वचिद्विशीतिं च तोवं प्रापयेत् । तथा जीवीनय-
वृंहणीयमधुवातहसिन्दूरभृङ्गोच्छ्वदनपरिवेकावाहैरन्नपानैश्च इहैरुपाचेत् ॥ (अ० सं० शां० ३/२८)

मुक्तगभापरां योनिं तैलोनाङ्गं च मर्दयेत् ॥ ११ ॥

वातज्वायधतोयं वा तथा चार्ज्यं कृण्वति । निष्काम्यति ॥ १४॥
 स्तू॥॥॥॥ स्तुवता तलाद् धृताद्वा महता पवत् । पञ्चकालकिर्णं मात्रामनुचोषां
 गुडोदकम् ॥ १४॥

स्नेहायोग्या तु निःस्नेहममुमेव विधिं भजेत् । पीतवत्याश्च जठरं यमकाकं विनोषयेत् ॥ १०८ ॥

पूर्वात्तोषधसाधिताम् । अह्नादूर्ध्वं विद्यायादिवर्गकवायेन साधिता ॥ १७॥

पिशितं नोपयज्येत । यन्नेनोपयजेन्नानं ॥ १८ ॥
ब्रह्मसाहेनतिक्रान्ते

सूक्तिकाया विशेषेण रक्षोघ्नानि हितानि च ॥ १८२ ॥ (का० छि० १०)

उद्धकम् तु सुतानां सावशेषमतः परम् । संप्रवक्ष्यामि कात्तनयेनं तन्निबोध यथाक्रमम् ॥ ३॥

प्रजातमात्रमाश्रयस्य सुतां शक्यता विजाग्रेसारिका ॥ न्यूनं शयानां मंडाद गणं गच्छिन्म कश्चित् ॥
दशवदशकुलसात्पत्यः ॥ १९॥

गर्भदोषप्रवृत्तये । महताऽदुष्टपट्टेन
कुक्षिपार्वे च वेष्टयेत् ॥ १९ ॥

अध्यासीत सदा सता तथा योनिः पर्याजति । सिद्धं त्वं नै
स्वसंस्थानं याति वायुश्च श्वाप्यति । चर्मवन्द्वापासन्दीं
बलातौलोष्णपूरिताम् ॥ २० ॥

स्वित्रामुष्णाम्बुना स्नातां विश्रान्तां विगतकलमाम् । कक्षगगल्वगभिर्घर्षयेद्वनम्यदैः ॥ ३३ ॥

लताऽननबलव(वि)द्वीक्ष्य अहं पञ्चाहमेव वा । मण्डानुपानमवक्षं पिबेत् स्नेहं हिताशिनी ॥ २३ ॥

अनिम को फोटा, डायनाम, सप्लो का विलेय। कर।

सन्नेहव्यापारमंश्जनीयादल्पसन्नेहाममैश्वर्याम् । दयापूर्वं श्रद्धामेवात्र पिप्यतीनागराश्चिताम् ॥ २४॥
स्याद्व्यपेतीषथा पथ्यात् सन्नेहलवणोत्तरा । कुलस्थपूरुः सन्नेहलवणामस्तसतः परम् ॥ २५॥
तथैव जाङ्गलसः शकाानीमानि चाप्यतः । घृतभृष्टानि कृष्णगडूलकैर्वारिकाणि च ॥ २६॥
सन्नेहस्वेदी च सेवेत मासमेकमतिद्विता । उष्णादकोपचारं च स्वस्थवृत्तमपः परम् ॥ २७॥
कुलसातव्यं च बुध्येत यस्मिन् यस्मिन् यथा यथा औचित्यात् कुलसातायस्य ततश्चैवानुवर्तते ॥ २८॥
अतो नैकान्तिकलाव्य सुनिकोपक्रमस्य च । देशं च जाति सातव्यं च संप्रधायं प्रयोजयेत् ॥ २९॥
(का० सं० चिह्न)

(का० सं० खि० ११)

सूतिका को पूछू लगी है यह जानकर उसके सान्त्व्य का (घृततैलादि को सान्त्व्यता का) ध्यानु रखते हुए शक्ति के अनुसार (जितना स्नेह बल-विशेषी न हो या पच जाय) पिपल्ली, पिप्पलीमूल, चूला, चित्रक तथा शृङ्गवेर के वर्ण से दूध घृत, तैल, वसा अथवा मज्जा का पान कराए। स्नेह पी लेने के बाद घृत एवं तैल से अष्टाङ्ग (उदर का) करके उदर को बड़े एवं निर्मल वस्त्र से (भली भाँति दबाकर) लपेट दें। इस प्रकार करके से अक्काश न रहने के कारण वायु विकृति नहीं उत्पन्न करती। स्नेह के पच जाने के बाद पिप्पल्यादि (उपर्युक्त पौर्वा) आधियों से ही समिध घृत-युक्त पतली यवणा का पान कराए। दोनों समय स्नेह तथा यवणा के पान के पूर्व उष्णोदक से परिषेचन कराए। इस विधि को पाँच या सात रात्रि पालन करके क्रमशः आय्यानु (बृहण चिकित्सा या मांसवत्तबद्धक उपाय) करना चाहिए। टीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है कि परिषेचन के बाद भ्रात-काला स्नेहपान कराए, स्नेह के वर्ण हो जाने पर पुनः परिषेचन करके यवणा पिलाए। यह विधि आनुप देश की स्थियों के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ के प्राणियों में कफ की प्रबलता रहती है, जाङ्गल देशवासियों के लिए इसे प्रयोग करना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि सूर्योत्तिका का बलातैल (पृष्ठ ५३३ से ५३६) से अप्यूङ्ग करके वातर औषधियों (भद्रदात शशांगक तथा कालादित्य भस्म आदि) के क्वाथ से उपचार करें अर्थात् पान एवं परिष्के आदि में प्रयोग करें। दोष शेष रह जाने पर (गर्भाशय में दोष अर्थात् रक्त) के रह जाने पर उसी दिन पिप्पली, पिप्पलीमूल, हस्तिपिप्पली, चित्रक तथा शूङ्गेर के चूर्ण को उष्ण गुडोटक के साथ पीने को दे। इस प्रकार दो या तीन रात्रि दुग्ध शोणित के निकाल जाने तक पिलावे। शुद्ध हो जाने पर नवरात्री-आदि गण की औषधियों से साधित स्नेह-यक्का अथवा क्षीर-यक्का (स्नेह या क्षीर युक्त यक्का) का तीन दिन (प्रसव के तीसरे) पा चौथे दिन से छठे या सातवें दिन) तक पान कराए। तत्पश्चात् (सातवें या आठवें दिन से) यव, कोल तथा कुलत्थ

इसका उल्ल जल को अधिक मात्रा से प्रायः परिषेचन करे तथा सूतिका क्रोध, व्यायाम एवं मैथुन आदि (पन्द्रह बातों का जो आतुरोपद्रव चिकित्सासार्गात् वर्णित हैं) का परित्याग करे। टीकाकार डल्हाण का मत है कि परिषेचन उष्णोदक को घारा से करना चाहिए जिसका उद्देश्य गर्भ-क्षोभ से उत्पन्न रक्त का स्राव कराना (अशुद्ध रक्त का स्राव कराना) तथा वायु को विजय कराना है।

परिपूर्ण काल में प्रसव होने के पश्चात् स्त्री का स्वेदन करना चाहिए ।

१. पौर्वाहिकः स्नेहपानपरिषेकः कारयितव्यः तथा जीर्णं स्नेहं परिषेचितं यवाणुः प्रायदित्येवार्थः । अयं तु व्यवहारो नानूपदेशे विन्द्यमानः किंत्वाङ्गलदेशे व्यवहार इति श्रेयम् ॥ (च० सं० शां० ८७८ की चक्र० टीका)

२. वातहर्षौषधानि भद्रदार्वादीनि । उपपेतं 'पानपारिकदादिधः' इति शेषः । सशेषदोषादिपंचर दोषशब्दो रक्तचवनः ॥
(सु० सं० शा० १०/१६ की इल्लहण टीका)

३.! एतां रिशयं परिधिञ्चेत् धाराया, गर्भक्षेमकृतात्कलावर्णाथं वातजयाथं च । क्रोधादयः पञ्चदश आधुनोपद्रव-
चिकित्सितोकाः । (सं० सं० शां० १०/१८ को उद्धरण टीका)

४. सु० सं० चि० ३२/१८ (पृष्ठ ५३२)

सूक्तिका-विज्ञानीय

424

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि सूतिका का चलनैतल (पृष्ठ ५३३ से ५३४) से अभ्यङ्ग करे। उसे भूख लगने पर पश्चकोल चूर्ण अथवा यवाती, उपकुष्ठिका, चव्वा, त्रिवक्त्र, व्णोष तथा सैन्धव के चूर्ण के साथ दिन भर में पच जाने योग्य मात्रा में यशसासत्पत्र स्नेह पीने को दें। स्नेह पान के अयोग्य (स्त्री) को वातहर औषधियों अथवा लघुपञ्चमूल का क्वाथ पीने को दें। इस पान के पश्चात् घृत एवं तैल से अभ्यङ्ग (उदर का) करके उदर को कपड़े से लपेट दें इससे अवकाश न मिलने के कारण वायु विकृति नहीं उत्पन्न करती। स्नेह के पच जाने पर पूर्वोक्त औषधियों या विदयारिण का की औषधियों के क्वाथ या दुग्ध के साथ भली भाँति पकाई हुई पचती यवाणु मात्रा के अनुसार पीने को दें। स्नेह एवं यवाणु के पान के पूर्व दोनों काल (प्रातः एवं सायं) उष्णोदक से परिचयन करें।

इस विधि का तीन पाँच या सात रात्रि (बलावल के अनुसार) तक पालन करके तत्पश्चात् यय, काल एवं कुलतय के यूथ के साथ लघु अन्नपान प्रयोग करें। बारह रात्रि के पश्चात् अग्न एवं बल को ध्यान में रखकर जाङ्गल मांसस आदि से क्रमशः आप्यायन (बृंहण) करें। उबाल कर शीतल किया हुआ जल पीने को दें तथा जीवनीय, वृहणीय, मधुर एवं वातहर (औषधियों) से सिद्ध (तैल या घृत या क्वाथ से) अभ्यङ्ग, उदरतीन, परितक एवं अवगाहन तथा हृद्य अन्न-पान से उपचार करें।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि गर्भ एवं अपरा से मुक्त हो जाने के बाद स्त्री को यौनि एवं अङ्गों का तैल स मर्दन करे। मूख लगाने पर सूतिका तैल या घृत की महती मात्रा (आठ याम में पच जाने योग्य मात्रा) में पञ्चकोल का चुर्ण मिलाकर पान करे तत्पश्चात् उष्ण गुड़ोकर अथवा वातहर औषधियों का तोय (क्वाथ) पान करे। यह क्रम दो या तीन रात तक करे, इससे जायु प्रकुपित नहीं होती (अन्यथा शून्य-कोष्ठ को प्राप्त कर कुपित हो सकती है) तथा टुट्टर का शोधन हो जाता है। स्नेहपान के अयोग्य स्त्री को उपर्युक्त (औषधियाँ) स्नेह के बिना ही दें, इस पान के पश्चात् घृत एवं तैल से अभ्यङ्ग करके उदर का आवेष्टन करे। स्नेह के जीर्ण हो जाने पर पूर्वोक्त औषधियों से साक्षित पेया का पान करे। तीन रात्रि के पश्चात् सात्व्य के अनुसार विदार्यदिपान के क्वाथ से सिद्ध, स्नेह-शुक्र अथवा दुग्ध के साथ बनी यवग हितकारी होती है (इस प्रकार ७ रात्रि तक प्रयोग करें)। सात रात्रि के पश्चात् क्रमशः बृंहण (जीवनीय, बृंहणीय, मधुरवर्णा वी औषधियों से सिद्ध अभ्यङ्ग, उर्ध्वत, पार्ष्णिक एवं अक्वाह तथा हृद्य अन्नपान^१) का प्रयोग हितकारी होता है। बारह दिन बीतने के पूर्व तक मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टीकाकार अरुणस्त का मत है कि यह निषेध स्कन्द आदि ब्राह्म ग्रहों से अभिषङ्ग होने के कारण किया गया है^२। इस प्रकार यन पूर्वक सूतिका का उपचार करें।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि सूक्तिका को विशेष काके रक्षणे एवं हित विधान का पालन करना चाहिए तथा लिखा है कि अब मैं देश, विदेश तथा कुल के सातव्य के आधार पर सामान्य तथा विशिष्ट उपक्रम विस्तार से कहूँगा-

प्रियवादिनी प्रसाविका प्रजातमात्र को आश्वसन देकर न्युब्ज (घुटने मोड़कर अधोमुख होकर या पार्श्व के बल पीठ को बाहर निकाले हुए लेटकर) शयन काराकर पीठ का संवाहन (हाथ से मांतिश) करके, कुक्षि को दबकर, (गर्भ को प्रसवित करने के लिए) वायु (अपान) के द्वारा प्रचालित उदर की मांतिश करते हुए गर्भ-जन्म दोषों की प्रवृत्ति के लिए दबाए, तत्पश्चात् बड़े एवं स्वच्छ कपड़े से कुक्षि तथा पार्श्व को लपेटें, इससे उदर स्वस्थान में चला जाता है तथा वायु का भी शयन होता है। प्रसूता स्त्री उष्ण बलतैल से पूरित चर्मावनाम्ब (चमड़े से मढ़ी हुई) आसन्दिना (छोटी कुर्सी) पर सदा बैठे, इससे उसकी योनि स्वस्थ हो जाती है एवं प्रियङ्गु आदि की बनी हुई कृया से (योनि का) स्वेदन करें। स्वेदन हो जाने के बाद गरम जल से स्नान तत्पश्चात् विश्राम काराकर शकान दूर हो जाने पर कुष्ठ, गुणुल तथा अगरह में घृत मिलाकर पूरन करें। तत्पश्चात् आग्नि एवं बल (अथवा आग्नि के बल अथवा पाचनशक्ति) को देखकर तीन या पाँच दिन मण्ड

१.अष्टाभिर्यैर्वा जरां गच्छति सा स्नेह मात्रा महती ।.....वायुर्नृप्यति न कोपं याति शून्यकोष्ठं प्राप्य।

बृंहणं च जीवनीयबृंहणीयमधुरागसिद्धैः पशुद्वतर्तपरिषेकावाहैर्हृद्यैश्चापानैर्विघ्रातव्यम्। नाप्यवहायेत्, स्फुन्द्यादिद्वदशग्रहभिषङ्गपरिहारार्थम् । मांसभोजनेन हि कदाचित्तैरिषङ्गो भवेत्।

(अ० ह० शा० १/९४, ९५, ९८, ९९ अरण० टीका)

का पान कराए एवं उसके बाद हित भोजन करने वाली स्त्री को स्नेहपान कराना चाहिए। स्नेह के जोणी हो जाने पर पिप्पली एवं नागर से युक्त लवण विरहित तथा अल्प-स्नेह युक्त यवागु को तीन दिन तक देना चाहिए। उसके बाद (कुल ६ या ७ दिन के बाद) औषधियों से युक्त पर्याप्त मात्रा के लवण तथा स्नेह से युक्त यवागु का सेवन करना चाहिए। इसके बाद स्नेह, लवण तथा अम्ल से युक्त कुलतथ-यूष एवं जाङ्गल मांसरस का सेवन तथा कृष्णण्ड, मूलक एवं एतारिक आदि शाकों को भी भूत कर खारा। प्रसव के बाद स्त्री को एक मास तक तन्त्रा से रहित होकर स्नेह, स्वेदन तथा उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, यह सूक्तिका का (सामान्य) स्वस्थवृत्त है। जहाँ जहाँ जिस-जिस प्रकार का कुल-सातत्य ज्ञात हो उस कुल-सातत्य के औचित्य को ध्यान में रखकर उस प्रकार का आचारण करना चाहिए। सूक्तिका के उपक्रम को एकात्मिक (एक देशीय) न समझना चाहिए। देश एवं जाति के सातत्य को आधार मानकर (विकिरता या पथ्य का) प्रयोजन करनी चाहिए। प्रसूता को स्नेह के प्रयोग का निषेध किया गया है^१।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि प्रसव के पश्चात् लोभ, अर्जुन, कदम्ब, देवदार, बौजक तथा कर्कशु में से यथा उपलब्ध द्रव्यों (के क्वाथ) को रक्त को शुद्ध के लिए देना चाहिए इससे प्रसूता स्त्री को योनि शुद्ध हो जाती है। तैल से आप्रण (योनि का) तथा अप्यङ्ग करके उष्ण जल से स्वेदन करें। (पहिले दिन) उपवास करके दूसरे दिन नागर, हरीतकी तथा गुड़ (खाने को) दें। दोपहर के बाद उष्ण कुलतथ-यूष पीने को दें। तीसरे दिन पञ्चकोल को यवागु, (चौथे दिन) चतुर्जातक मिश्रित यवागु तथा पाँचवें दिन शालि या शण्डिक धान्य का ओदन भोजन करने को दें। इस प्रकार दस या पन्द्रह दिन उपचार करें। इस प्रकार श्रेष्ठ वैद्य बाहवें दिन मङ्गल-वचन करके योषार्थ (घर की अन्य स्त्रियों को तथा मङ्गल गीत आदि) दिखावे, या उनमें मिलने को आज्ञा दे।

भावप्रकाश में संक्षेप में लिखा है कि प्रसूता स्त्री को हित या योग्य आहार-विहार का सेवन करना चाहिए तथा व्यायाम, मैथुन, क्रोध एवं शीत-सेवन का परित्याग कर देना चाहिए। उसे एक मास तक अतिद्रुत या सचेष्ट होकर निमग्न, पथ्य एवं अल्प भोजन वाली तथा नित्य स्वेद एवं अप्यङ्ग प्रयोग करने वाली रहना चाहिए। इस प्रकार से वह भली-भाँति शूद्ध हो जाती है।

योगरत्नाकर पुस्तक में उपर्युक्त भावप्रकाश के वर्णन के ही साथ प्रसव के तुरन्त बाद वायु के प्रवेश से संरक्षण के लिए योनि को दबाने का भी निर्देश है^२।

आचार्यों ने बालक के रक्षकर्म का वर्णन किया है जो सूक्तिकागार में स्थित बालक में किया जाता है। महर्षि चरक

१. न स्नेहयेदग्निर्भर्णी न प्रसूतां१। (का० सं० २२/३०)

२. प्रसूतानन्तरं रोषार्जुनकदम्बदेवदारवाजकाहं कर्कशूक्ष्ण यथालाभं लोहितविशुद्धे दापयेत्। प्रसूतिजाला योनिः संशोष्यते ॥ तैलेनाप्यङ्गं चोष्णेन वारिणा स्वेदयेत्। उपवासमेव कृत्वा द्वितीये दिवसे गुडनागरहरीतकीश्च दापयेत्। द्वययोगोर्ध्व कुलतथयूषं वा सोष्णं पापयेत् ॥ तृतीय दिवसे पञ्चकोलयवागुर्दापयेत्। चतुर्जातक मिश्रा यवागुर्दापयेत् ॥ पञ्चमेऽहनिशालिण्डिकीदन्तं भोजयेत् ॥ अनेन क्रमेण दशपञ्चदशाहं चोपचारयेत् ॥ १॥

एवं कृत्वा च नारीणां द्वादशाहं भिषावः। मागल्यं चाचनं कृत्वा योषार्थश्च प्रदर्शयेत् ॥ ५॥ (हो० सं० तु० स्था० ५३/१ व ५)

३. प्रसूता हिममहर्षं विहारं च समाचरेत्। व्यायामं मैथुनं क्रोधं शीतसेवां विवर्जयेत् ॥ २॥

सर्वतः परिशुद्धा स्नास्तिनमपथ्याऽल्पभोजना। स्वेदाप्यङ्गपरा नित्यं भवेन्मासमतिद्रुता ॥ ४॥ (पा० प्र० पूर्व० ४)

प्रसूता युक्तमाहारः.....शीतसेवाश्च वर्जयेत् ॥ १४५॥

सर्वतः.....तिद्रुता ॥ १६५॥ (पा० प्र० चि० ७० उपर्युक्त सदृश ही)

४. पृथिव्यां पतिते वत्से यो नै पिण्डनिमग्न्यते। अपवेशो यथा वायोऽस्त्रथा संरक्षणक्रिया ॥

प्रसूता.....वर्जयेत् ॥ सर्वतः.....मतिद्रुता ॥ (पा० प्र० चि० ७० की ही भाँति) (यो० २० स्त्री० चि०)

ने स्पष्टतया इसे बालक एवं सूक्तिका दोनों का ही रक्षकर्म माना है। इस रक्षकर्म का तात्पर्य सूक्तिका एवं बालक का ग्रह या भूतार्थभिवेश (औसर्गिक व्याधियों) से संरक्षण है, अतः अध्याय १० में वर्णित रक्षकर्म को भी सूक्तिकापरिचर्या का अङ्ग समझना चाहिए।

आचार्यों ने सूक्तिका को आश्वपान,^३ शिराबोध,^४ नस्य,^५ विरेचन^६ एवं स्वेदन^७ का निषेध किया है। महर्षि शार्ङ्गधर ने प्रसव के पश्चात् स्वेदन^८ तथा बालतैल का प्रयोग प्रशस्त माना है।^९

महर्षि वाग्भट ने सूक्तिका को बृंहण के योग्य माना है^{१०} है। महर्षि काश्यप ने मण्ड-प्रयोग का निर्देश दिया है।^{११}

In general all the classics have advised massage, oral administration of fats with medicines and decoctions for three to seven days after delivery. Use of medicated rice gruel is prescribed in diet. From seventh or twelfth day medicated meatsoup is advised. However, there is slight difference of opinion in the list of drugs amongst various authors.

Caraka says that when puerperal woman feels hunger she should be prescribed powdered *pippli*, *pipplamūla*, *cavya*, *citraka* and *śrngadhara* with any one out of *ghrita*, oil, *vasa* (animal fat) or *majja* (marrow) considering her tolerability for these, and in the quantity which she can digest easily. After ingesting this, her abdomen should be massaged and wrapped properly with a big clean cloth. This wrapping produces compression of abdomen, thus prevents presence of hallow space, so the *vayu* does not get vitiated. After digestion of *ghrita* etc. fats, liquid gruel made with rice and medicated with *pippli* etc. drugs mentioned above and mixed with *ghrita* should be given. During both the times i.e. morning and evening irrigation or bath with hot water should precede use of *ghrita* etc. and rice gruel. Cakrapāṇi says that in the morning irrigation should be given before ingestion of oleaginous substance and should be repeated after its digestion, afterwards rice gruel should be given. After use of this regimen for five or seven nights (day and nights) gradual administration of *vinhana* substances (anabolic or likely to increase flesh and energy) should be done. This regimen is not suitable for the women of *ānūpadeśa* (marshy land), because in the persons of this area the *kapha* is dominant. This regimen is suitable for the woman of *jāṅgala* (wild or dry) area.

१. च० सं० शा० ८/७९; सु० सं० शा० १०/२३; अ० सं० उ० १/१६ से १८ (अध्याय १० में वर्णित)

२. अनास्थाप्यासु.....विसूचिकामप्रजाला१। (च० सं० चि० २/१४)

३. अ० सं० सू० ३६/८ एवं अ० ह० सू० २७/७

४. अ० सं० सू० २९/१९ एवं अ० ह० सू० २०/१२

५. सु० सं० चि० ३३/३०; शा० सं० उ० ४/८ एवं अ० पा० प्र० पूर्व० २-५/७०

६. अ० सं० सू० २६/३२ एवं अ० ह० सू० १७/२४

७. पञ्चान्वेद्या.....प्रजाला१। (शा० सं० उ० २/८)

८. शा० सं० मध्य० ९/१९४ से १९८ (पृष्ठ ५३३ से ५३६)

९. अ० सं० सू० २४/११

१०. सद्यः प्रसूतास्त्रि चाङ्गनासु मण्डं विदध्यात्१। (का० सं० कल० ७/६४)

Suśruta says that after applying massage with *balātaila* (described under obstructed labour) the puerperal woman should be prescribed decoction of *bhadraḍāru* etc. drugs capable of suppressing the *vāta* for oral administration or irrigation. If some *doṣas* or blood is still left inside (some blood clots are retained in uterus), powdered *pippalī*, *pippalīmūla*, *hasipippalī*, *citraka* and *śringavera* with warm jaggery-water should be given. This should be continued for two or three days till the abnormal blood (*lochia rubra*) is properly excreted. Afterwards rice gruel prepared with the drugs of *vidāringandhādi* group and mixed with *ghṛta* or milk should be given for three days (from third or fourth day to sixth or seventh day after delivery). Then (from 7th or 8th day) cooked *śālī* rice with meat soup of wild animals prepared with *yava*, *kola* and *kulathā* should be prescribed considering her strength and digestive power. Normally the woman should be given good irrigation with hot water and should avoid anger, exercise and coitus. Dālhana says that irrigation should be done by pouring water in a stream, so that abnormal blood (accumulated in uterus) produced due to irritation by *garbha* (delivery) is excreted properly and *vāta* is also suppressed. After delivery of full term fetus the sudation should be given.

Vāgbhata I has mentioned that massage with *balātaila* should be given to the puerperal woman. After feeling of hunger she should be given congenial oleaginous substances mixed with either powdered *pañcakola* or powder of *yavānī*, *upakūñcikā*, *cayya*, *citraka*, *vyoṣa* and rock salt, in the quantity which she can digest in whole day. The woman unfit for use of oily substances should be given decoction of either *laghupañcamūla* or drugs capable of suppressing *vāta*. After this oral administration of oily substance or decoction, her abdomen should be massaged with *ghṛta* and oil and wrapped with cloth to prevent vitiation of *vāyu* likely to occur due to availability of hallow space. After digestion of oleaginous substance, liquid rice-gruel properly prepared with either above mentioned drugs or *vidāryādi* group of drugs or milk should be given in the quantity which she can digest properly. During this entire period morning and evening irrigation with hot water should precede use of *ghṛta* etc. or rice-gruel. This regimen used for three, five or seven nights should be followed by use of light diet with soup of *yava*, *kola* and *kulathā*. After twelve nights giving due consideration to strength and digestive capacity, gradual satiation or strengthening should be done by use of meat soup of wild animals, besides, oil, *ghṛta* or decoction prepared with *jīvanīya*, *vr̥nhanīya*, *madhura* and *vātahara* drugs should be used in the form of massage, unguent, irrigation and bathing. Agreeable diet or drinks should also be given.

Vāgbhata II has also given almost similar description as Vāgbhata I, however, he has advised massage of even *yoni* alongwith body and use of hot jaggery-water just like Suśruta. Arunadatta has explained that if meat preparations are used before twelve days, it invites the danger of infliction by *skanda* etc. twelve *grahas*.

Kāśyapa says that the puerperal woman should use specifically *rakṣoghaṇa* (antiseptic) and beneficial things. Detailed management should be done giving due consideration to place of living (*deśa* and *videśa*) and traditions of the family. The woman immediately after delivery should be encouraged by sweet-spoken accoucheuse, and made to lie down in

hunch-back position. Now she should rub her back, press her abdomen/flanks and then compress her abdomen having been moved by *vāyu* (entire musculature of abdomen acts with force due to effect of *apāna vāyu* to expell the fetus) in order to expel the *doṣas* left-over after delivery. After this, abdomen and flanks should be wrapped with clean big cloth, by this wrapping abdomen reaches its proper place and *vāyu* also subsides. The puerperal woman should always sit over a small chair covered with leather-bag filled with hot *balātaila*, with this her *yoni* becomes healthy. Sudation in the *yoni* should be given with oleo prepared with *priyangu* etc. drugs. After proper sudation hot water bath followed by rest should be given, after overcoming the tiredness, fumigation with *kustha*, *guggulu* and *aguru* mixed with *ghṛta* should be done. Now, considering her strength and digestive power scum of boiled rice should be given for three or five days, then the woman using beneficial diet should take orally oleaginous articles (oil, *ghṛta* etc.). After digestion of this oil etc. salt free rice gruel mixed with little quantity of oleaginous substance and powdered *pippalī* and *nāgara* should be given. This should follow (after 6 or 7 days) use of rice gruel mixed with sufficient quantity of salt and oleaginous substance, then meat soup of wild animals and soup of *kulathā* mixed with oleaginous substance, salt and sour articles and *kūśmāṇḍa* (a kind of pumpkin-gourd), radish, cucumber etc. vegetables fried in *ghṛta*. After delivery the woman should use oleation, sudation and hot water with full alertness for one month. The management of puerperal woman should not be considered in isolation, due consideration had to be paid to traditions as well as beneficial things or diet to the family and also place of living. Sudation is contraindicated.

Hārīta has advised that after delivery the decoction of available drugs out of *ladhra*, *arjuna*, *kadamba*, *devadāru*, *bijaka* and *karkandhu* should be given for purifying the blood and also *yoni*. Vaginal filling with oil and massage followed by sudation with hot water should be done. After fasting for first day, on second day in the morning *nāgara* and *haritākī* with jaggery, then in the afternoon warm soup of *kulathā* should be given. Rice gruel mixed with *pañcakola* or *canjīrāka* should be given on third and fourth day respectively, on fifth day cooked *śālī* or *śaṣīka* rice be prescribed in diet. This regimen should continue for ten or fifteen days. The wise physician should permit the puerperal woman to see or meet other women on twelfth day.

Bhāṇḍaprakāśa has given very short description, that the puerperal woman should use congenial diet and mode of life, give up exercise, coitus, anger and cold air. She should use unctuous, light, congenial diet and daily sudation and massage for one month with full alertness. Yogarānākara has added that immediately after delivery her vaginal canal should be pressed to avoid entry of air.

Authors have advised various protective measures described in chapter ten to prevent mother and new born child from the seizure by *grahas* or *bhūtas* (infection), thus this also forms a part of management for puerperal woman.

Use of *āsthāpāmbasī* (evacuative enema), venesection, stimulatory drugs, purgatives and sudation is contraindicated, however, Śārngadhara has advised sudation after delivery. She is fit for the use of *br̥nhanā* drugs. Use of *maṇḍa* is beneficial.

..... गजानाम आमक्तो दोषः स्यात् ॥ (च० सं० सि० २/१५)

प्रजाता स्ना (सूतका) का आशाना माता दत्ता

Use of *āsthāpāna basti* (evacuative enema), increases urine output

ई) सूतिका को नस्य देने का परिणाम (Effect of nasya or stimulatory drugs)

सुतराकस्य क्षमातामनाद्यभंगनाद च ॥ सूत्राभावात् सुतराकस्य क्षमातामनाद्यभंगनाद च ॥ (आ० सं० सू० २५/११)

सूतिका को नस्य देने से सुतारक (रक्त नाकाल हुऐ आका) सधुस रा जगाने सन १८००

If *nasya* is given to a puerperal woman, she develops emaciation, anorexia and bodyache.

7) मनिकापरिचर्या से लाभ (*Benefits of this management*)

इ) स्यात्कारणं च तस्यैव । इति चेन्न । ननु तदा तत्रापि भवति ॥
एवं हि गर्भवृक्षप्रितशिशिलसर्वशरीयातुप्रवाहणवेदान्तेन कान्तिस्रुतिविषेषधून्मशीराच्च पुनर्नवीभवति ॥
(अ० सं० शा० ३/३९)

इस प्रकार (पूर्व पृष्ठों में वाणिज्य सूतिकापरिवर्धन का प्रयोग करने से) गर्भवृद्धि के कारण कृश होने- सभी शरीर को धातुओं के शीथल होने तथा प्रवाहण की वेदना एवं क्रोड तथा रक्त निकलने के कारण विशेष रूप से शुन्य शरीर को घटाने के लक्ष्य है अर्थात् उसका शरीर एवं धातुएँ पूर्ववत् हो जाती हैं ।

हुइ स्त्रो युः नारो शान्दो च ॥ १॥

The woman becomes weak or emaciated due to development of fetus and also empty bodied due to unsteadiness or languor of all the *dhatu*s, labour pains and excretion of *kleda* (moisture) and blood. With this regimen she attains all the lost things and reaches her pre-pregnancy stage.

pregnancy stage;
क) देशादि के आधार पर विशिष्ट सूक्तिकाचर्या (Specific puerperal management on the basis of place of living etc.)

त्रिविधं देशगामश्रित्य वक्ष्यामि त्रिविधं विधिम् ॥ २८॥ (कां सं० छि० १९/२८)
त्रिविधं देशगामश्रित्य वक्ष्यामि त्रिविधं विधिम् ।
वर्णन करेगा ।

Now the puerperal management would be described on the basis of all three living places.

१) आनूपदेशस्य सूतिकापरिचर्या (Management for puerperal women of ānūpaśa dēśa or living in marshy land)

आनुपदेशे भूगुष्ठं वातश्लेष्मानका गदाः ॥ २८ ॥
 तत्राभिष्यन्दभूपरत्नादादौ स्नेहो विगर्हितः । पाण्डादिरत्र कर्तव्यः संसर्गोऽनिबलानहः ॥ २९ ॥
 तेने विन्यासं मार्गिण्यं च गणयते ॥३०॥ (काण सं० खि० ११/२८ से ३०)

येने विष्णुपात्रं गर्वाणां न शस्यते ॥ ३० ॥ (का० सं० खि० ११/२८ से ३०)

स्वेदी। नवतश्चिदप्यन सधनुषा। च दशमः प्रत्ययः - इति ।
आनुदेश में विशेषकर वात एवं श्लेष्मा की बीमारियाँ होती हैं। वहाँ पर अभिष्यन्द या कसेद की प्रधानता के कारण
प्रारम्भ में स्नेह (प्रयोग) निन्दित है यहाँ पर अग्नि एवं बल-वर्धक मण्डीद प्रयोग करना चाहिए तथा स्वेदन, वायु-रहित

[illegible]

स्थान में ज्ञान एवं सभी उष्ण द्रव्यों का सेवन श्रेयस्कर है ।

चक्रपाणि ने आनूपदेशस्थ सूतिका को स्नेहपान वर्जित किया है।^१

Kāśyapa says that in marshy land usually diseases of *vata* and *śleṣmā* occur. Due to dominance of moisture in this area initially fat should not be used, instead scum of boiled rice treated with appetizing and strength producing things should be given. Sudation, sleeping in air free place (direct entry of air should not be there) and use of all *usna* (hot) drugs is beneficial. Oleaginous substances should be avoided is the opinion of Cakrapāṇi.

२) जाङ्गलदेशास्य मुक्तिकापरिचर्या (Management of puerperal women of jāṅgala deśa or living in wild or dry place)

धन्वभूमिजातां तु सूरिकां घृततैलयोस्तारस्य मात्रां प्रापयेत् पिप्पल्यादि कषायानुपानं, स्नेहिन्या च स्यात् त्रिशात्रं पञ्चशात्रं वा बलवतीं अबलां यवापां प्रापयेत् त्रिशात्रं पञ्चशात्रं वा । अत ऊर्ध्वं स्निग्धेनान्नसंस्पर्शोपपद्यते ॥

प्रायश्चर्येन प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिञ्चेत् । क्रोधाद्यासमैश्वर्यादीन् परिहरेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/१७, १८)

नियतं जाङ्गले देशे वातपित्तात्मका गदाः ॥ ३० ॥

तदत्र स्नेहसाम्यत्वात् स्नेहादिः स्यादुपक्रमः । कार्यः प्रजातामात्राया विशेषश्चान्न बुध्यते ॥ ३१ ॥

(का० सं० खि० ११/३०, ३१)

जगन्नालदेश में प्रसृत हुई स्त्री को पिपलायादि कथाय (सामान्य सूक्तिकापात्रिचर्चात्नार्गत वर्णिता) के अनुपान से घृत, तैल या अन्य स्नेह को मात्रा के अनुसार पिनाए। (इस प्रकार) बलवती प्रसृता को तीन या पाँच रात्रि तक स्नेह पान करायेँ, अवला या बलारहित स्त्री को तीन या पाँच रात्रि तक यवगू पान करायेँ। तत्पश्चात् स्निग्ध अन्न से संसर्जन क्रम के अनुसार उपचार करें। प्रायः इसका उष्णोष्णिक को प्रभूत मात्रा से परिरिक करें तथा यह क्रोध, व्यायाम एवं मैथुनादि का त्याग करे।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि जाङ्गलदेश में वात एवं पित्त की व्याधियाँ अधिक होती के कारण सद्यःभूता का विशेष रूप से स्नेह आदि से उपचार करना है ऐसा जानना चाहिए।

टीकाकार चक्रपाणि ने भी जाङ्गलदेश में स्नेहप्रयोग का वर्णन किया है^१।

The woman of this area should be given *ghrita* or oil or any other oily articles in good quantity using decoction of *pippali* etc. drugs (described under general management) as after-drink. To the strong woman this oleaginous substance and to the weak woman rice-gruel should be given for three or five nights. This should follow the use of cereals mixed with unctuous things in gradually increasing manner. She should often be irrigated with good quantity of hot water and should avoid anger, exercise and coitus.

Kāyapa says that in wild places diseases of *vāta* and *pitta* often occur. Since oleaginous substances are congenial in these areas, they should be used in abundance.

Cakrapāṇi also says that oily substances should be used in good quantity.

३) साधारणदेशस्थ सूतिकापात्रिचर्चा (Management of puerperal women of sādāharaṇa deśa or living in ordinary place)

देशे साधारणे चास्या हितः साधारणी विधिः ॥ (का० सं० खि० ११/३३)

१. च० सं० शा० ८/४८ की चक्रपाणि टीका (पृष्ठ ५४८)

साधारण देश में इसके लिए साधारण विधि हितकारी होती है।

For woman of ordinary area general or average (use of neither too oleaginous nor dry substances) management is beneficial.

४) विदेशी जातियों के लिए पथ्य (Management for foreigners)

हेतुश्याश्र प्रयच्छति विविधा स्नेच्छजातयः। रक्तं मांसस्य निर्वृहं कन्दमूलफलानि च ॥ ३४॥
(का० सं० खि० ११/३४)

अनेक विदेशी एवं स्नेच्छ जाति के लोग (इस अवस्था में) रक्त, मांसनिर्वृह तथा कन्द, मूल एवं फल आदि का प्रयोग करते हैं।

Women of *mleecha* caste and other foreigners use blood, meat soups, eatable roots, phyzomes and fruits during this period.

५) पुत्र अथवा पुत्री के जन्म के बाद सूतिका-पथ्य (Puerperal management according to sex of child)

कुमारप्रसवे तैलं कुमारप्रसवे घृतम्। भिबेजीपौ यवागुं च दीपनीयोपसंस्कृताम् ॥ ३३॥
पञ्चाहं सप्ताहं वा ततो मण्डाद्युपक्रमः ॥ (का० सं० खि० ११/३२ व ३३)

स्त्री को पुत्र उत्पन्न होने पर तैल एवं पुत्री उत्पन्न होने पर घृत पीने को दें, इसके जीर्ण हो जाने के बाद दीपनीय औषधियों से संस्कृत यवागुं पीव या सात दिन पीने को दें तत्पश्चात् मण्ड आदि का क्रम दें।

Oil or *ghrita* should be given for drinking in case of delivery of male or female child respectively. After proper digestion of this fat, rice gruel prepared with appetizing drugs should be given for five or seven days, then scum of boiled rice etc. should be used in a gradual manner.

ए) प्रसूता-स्नान (Bath to a puerperal woman) 10-12 दिन देखाए जाता है।

दशमे द्वादशे चाह्नि गोत्राचारः शुभैः शुभे। सूता स्नानोत्सवं कार्यात् ॥ (अ० सं० उ० १/२७)

दशम या द्वादश दिन शुभ दिन देखकर गोत्र के आचार (नियम) के अनुसार सूतिका का स्नानोत्सव करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णन को ही अष्टाङ्गहृदयकार ने सूतिकोत्थान अर्थात् सूतिका को अपने सूतिकागृह से बाहर निकालने के नाम से दिया है जो इस प्रकार है-दशम दिन (प्रसव के बाद) पूर्ण होने पर अपने कुल की उचित विधि के अनुसार सूतिकोत्थान^१ अर्थात् सूतिकागृह से बाहर निकालने का कर्म करना चाहिए।

On auspicious period of tenth or twelfth day, according to rituals of family, the bathing ceremony of puerperal woman should be performed is the advice of Vāgubhata I. Vāgubhata II has advised *stutikoṭhāna* (coming out of the house) instead of bath.

सूतिका की व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा (Diseases of puerperal woman and their management)

बृहन्नयौ के आचार्यों ने सामान्यतः सूतिका-व्याधियों के कृच्छ्रसाध्य या असाध्य होने के निर्देश के पश्चात् सामान्य चिकित्सा-सूत्र का वर्णन कर दिया है। मकरल एवं रक्तविधि को छोड़कर किहीं विशिष्ट व्याधियों यथा ज्वर (सूतिका)

१. दशमे दिवसे पूर्ण विधिभिः स्तुकोत्थानैः। कारयेत् सूतिकोत्थानं॥ (अ० ह० उ० १/२२)

आदि का उल्लेख नहीं किया, जिसका सम्भाव्य कारण यह हो सकता है कि सूतिकाज्वर आदि में भी दीर्घ-दूष्य अन्य ज्वरादि-सदृश ही रहते हैं केवल चिकित्सा-सूत्र में वैभिन्न होता है। महर्षि कारयप तथा अन्य बाद के आचार्यों ने कुछ विशिष्ट व्याधियों तथा उनकी चिकित्सा का वर्णन किया है।

Caraka, Suśruta and Vāgubhata have given the principles of treatment for puerperal disorders after indicating that these are either incurable or are cured with great difficulty. Except *malkalla* and *raktaśāyā* other disorders like puerperal fever etc. have not been described by these authors, which might have been done with the idea that *dosas* and *dāyās* (etiopathogenesis) of these disorders are not different in any way from a common person, however, only principles of treatment differ. Kāśyapa etc. authors have described in detail certain puerperal disorders.

सूतिका की व्याधियों के कृच्छ्रसाध्य या असाध्य होने का कारण (Cause of incurability or difficult curability of puerperal disorders)

तत्प्राप्तुं खलु यो व्याधिरुच्यते स कृच्छ्रसाध्यो भवत्यसाध्यो वा, गर्भवृद्धिप्रतिशोधितसर्वधातुत्वात्, प्रबाहणवेदनकरोदनरक्तमिःसुतिविशेषशून्यशरीरत्वाच्च; विशेषतो हि शून्यशरीरः स्त्रियः प्रजात भवति।
(च० सं० शा० ८/४९)

(सु० सं० शा० १०/१९)

अत एव च सूतिकाया व्याधिः कृच्छ्रसाध्यो भवत्यसाध्यो वा। (अ० सं० शा० ३/४०)

(अ० ह० शा० १/१९, १००)

उस स्त्री (प्रसूता) को जो भी व्याधियाँ हो जाती हैं वे कृच्छ्रसाध्य या असाध्य होती हैं क्योंकि उसकी सभी धातुएँ गर्भ-वृद्धि के कारण क्षय-युक्त एवं शिथिल हो जाती हैं तथा प्रबाहण की वेदना एवं करोद तथा रक्तमिःसुति के कारण उसका शरीर विशेष प्रकार से शून्य (रक्त) हो जाता है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि म्रिय्याचार के कारण प्रसूता को जो भी व्याधियाँ हो जाती हैं वे कृच्छ्रसाध्य या असाध्य होती हैं क्योंकि वे अत्यधिक अतर्पण-जन्य होती हैं।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि इसलिये (गर्भ की वृद्धि के कारण धातुक्षयदि होने से) सूतिका को जो भी व्याधियाँ होती हैं वे कृच्छ्रसाध्य या असाध्य होती हैं।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि गर्भवृद्धि, प्रसव-वेदना, करोद तथा रक्तमिःसुति-युक्त शरीर होने से उसकी व्याधियाँ दुःसाध्य होती हैं।

महर्षि कारयप ने ज्वर के वर्णन के अन्तर्गत ही धातुक्षय के कारण शोषण-चिकित्सा-काटित्य एवं व्याधि की असाध्यतादि का उल्लेख किया है।

माधवनिदानकार ने सूतिका के अग्नि, मांस एवं बल के क्षीण होने के कारण उसमें उत्पन्न व्याधियों को कष्टसाध्य माना है।

१. अत एव गर्भवृद्धिप्रतिशोधितधातुवेत्त्यादिहेतुः। (अ० सं० शा० ३/४० की इन्द्र टीका)

२. कृच्छ्रसाध्य हि ते रोगाः क्षीणमांसबलान्निनः ॥ (मा० नि० ६/४)

भग्नप्रकाश तथा योरोत्नाकर पुस्तकों में भी उपर्युक्त अत्राय का ही वर्णन है ।

Since all the *dhtaus* decrease and become languid or unsteady due to development of fetus, body becomes empty due to labour pains and excretion of moisture and blood; her digestive power, muscle-mass and strength decrease; all the diseases occur due to *apatapana* (non-satiation) and purifying measures can not be given, hence the diseases developing during this stage become incurable or get cured with difficulty.

सूतिका की व्याधियों का सामान्य चिकित्सा सूत्र (General principles of treatment for puerperal disorders)

१) सूतिकाव्याधियों की निदान-परिचर्जन ही उत्तम औषधि है ।

२) यथोक्त-विधि अर्थात् स्नेहणानादि से, देश, काल तथा व्याधि के सात्त्व्य का विशिष्ट ध्यान राखकर चिकित्सा करने से सूतिका का नाश या मृत्यु नहीं होती । उसकी भलीभाँति पथ्य के द्वारा प्रयत्न से चिकित्सा करनी चाहिए ।

३) उसका भौतिक (भूतह), जीवनीय, ब्रह्मीय, मधुर तथा वातहर औषधियों से साधित (घृत, तैल या क्वाथ से) अभ्यङ्ग, उत्सादन, परिषेक, अवागह तथा अन्न-पान की विशिष्ट विधि से उपचार करें ।

४) कष्ट-प्रसव होने के कारण जो स्थियाँ रुण हो जाती हैं उन्हें स्नेहन एवं स्वेदन दें जिससे तत्काल ही वायु का शमन हो जाता है । बुद्धिमान वैद्य उसे दीर्घनीय औषधियों से पिष्ट-यन्त्रण पाने को दें। इससे वह स्त्री निरोग होकर सुखपूर्वक शयन करती है ।

i) Avoidance of etiological factors is the best medicine.

ii) She should be treated with good efforts by giving congenial diet and properly administering oleaginous substances with due consideration to the place of living, time factor and suitability for the disease. If these things are taken care of, she does not die.

iii) She should be treated with massage, anointment, irrigation and *ghrita*, oil or decoction.

१. अ) मिथ्याचारसूतिकाया यो व्याधिरुपजायते । स कृच्छ्रसाध्योऽसाध्यो वा भवेत्॥

(भा० प्र० पूर्व० ४/३, भा० प्र० चि० ७०/१५०, यो० २० स्त्रीरोग चि०)

अ) कृच्छ्र.....चलाधिरः । (भा० नि० सदृश) (भा० प्र० चि० ७०/१५०, यो० २० स्त्रीरोग चि०)

२. तस्मात् यथोक्तेन विधिनापेचते; भौतिकजीवनीयब्रह्मीयमधुरवातहरसिद्धैरप्यङ्गोत्सादनपरिषेकावागहनान्नपानविधिभिर्न शेषतश्चोपचरेत् ॥ (यथोक्तेन स्नेहणानादिना । सूतिकाव्याधिनान्नवर्जनरुपमुत्तमं भेषजमिति दशरथि । भौतिकं भूतह-चक्र० १) (च० सं० शा० ८/४९ एवं चक्र० टीका)

३. तस्मात् देशकालौ च व्याधिसात्त्येन कर्मणा । परिश्रयोचरोन्मित्येवं नालयमानुयात् ॥ (सु० सं० शा० १०/२०)

४. तस्मात् यथोक्तेन विधिना प्रयत्नोपचरेत् ॥ (अ० सं० शा० ३/४०)

५. याः कृच्छ्रेण प्रजायन्ते प्रसूताश्चामयन्ति याः । स्नेहस्नेहस्तस्मात्सं श्रियं वायुः प्रशाम्यति ॥ ४॥

यवार्णं दीपनीनां तु स्मृतिमान् दातुमर्हति । यथा शेते सुखं नारी नीरजा शयने सुखे ॥ ५॥ (का० सं० चि० ३)

६. अ) तत्पथ्यमाचरेत् । (भा० प्र० पूर्व० ४/३, भा० प्र० चि० ७०/१४६,)

अ) पथ्यं सनाचरेत् । (यो० २० स्त्रीरोग चि०)

७. अ० सं० ने इस विधि का वर्णन सामान्य सूतिकापरिचर्या में दिया है यहाँ पर यथोक्त-विधि शब्द का सम्भवतः तात्पर्य इसी पूर्ववर्तिन विधि से है ।

tion prepared with *bhūatika* (capable of eradicating *bhūta*), *jīvanyā* (life prolonging), *br̥mhanāyā* (anabolic), *madhura* (sweet) and *vātahara* (capable of suppressing *vāta*) drugs along with specific dietetics.

iv) The woman who is diseased due to difficult labour should be given oleation and sudation which suppress the *vāyu*. The wise physician should prescribe rice-gruel treated with appetizing drugs. With this the woman becomes healthy and sleeps well.

सूतिकाव्यापद (Puerperal disorders)

किञ्चिद् टपायि - ६८

सूतिका-व्याधियों की गणना (Number of puerperal disorders)

उत्पन्नम् (अदि) - ८५

महर्षि काश्यप ने सूतिका को होने वाली विशिष्ट व्याधियों की संख्या ६४ वर्णन करते हुए उनका नामोल्लेख खिलतस्थान के सूतिकोपक्रमणीय अध्याय में किया है । इसके पूर्व चिकित्सास्थान के दुष्प्रजाताचिकित्साध्याय में भी दुष्प्रजाता को होने वाली कुछ व्याधियों का वर्णन है जिसकी यद्यपि विशिष्ट संख्या का निर्देश नहीं किया पर वे ३५ हैं इनमें से २५ व्याधियाँ नामान्तर से सूतिकोपक्रमणीयाध्याय में भी वर्णित हैं परन्तु १० व्याधियाँ भिन्न हैं, इस प्रकार सूतिका की समस्त व्याधियों की संख्या ७४ हो जाती है जो निम्नांकित है-

दोनों स्थलों पर वर्णित व्याधियाँ - (१) योनिविभ्रता^१ या योनिभेद^२ (२) योनिशोफ^३ या योनिशूलना^४ । (३) योनिवेदना^५ या योनिशूल^६ (४) पुष्टशूल^७ या पुष्टभेद^८ (५) कटिशूल^९ या कटिभेद^{१०} (६) हृदिशूल (७) प्लीहा या प्लीहोदर (८) शाखवात (९) हनुस्तम्भ^{११} या हनुग्रह^{१२} (१०) मन्दास्तम्भ (११) शोफ^{१३} या शोथ (१२) कामला (१३) ज्वर (१४) अतिसार (१५) विसर्प (१६) छर्दि (१७) प्रवाहिका (१८) आभ्रान (१९) मूत्ररोध (२०) मलरोध (२१) अक्षिरोम (२२) कम्प^{१४} या वेपथु^{१५} (२३) वाताढीला (२४) वातगुल्म (२५) त्रिविचिका ।

दुष्प्रजाताचिकित्साध्यायान्तर्गत अतिरिक्त वर्णन - (१) असुतर (२) शूल (उत्तरशूल), (३) योनिदोष (४) मोह (५) दृढ (६) पाप्मा (७) कटिपिण्ड (८) विस्फोट (९) अर्धशिरोरुजा (१०) हस्त्रोप ।

सूतिकोपक्रमणीय अध्यायान्तर्गत अतिरिक्त वर्णन - (१) योनिप्रश (२) योनिक्षत (३) योनिस्त्राव (४) योनि-प्रसृता (५) पारवशूल (६) त्रिसूचिका (७) महोदर (८) अङ्गमर्द (९) प्रक्षेपक (१०) अपलातक (११) मक्कल्ल (१२) विद्विष (१३) प्रलाप (१४) मूत्रसङ्ग (१५) उन्माद (१६) दौर्बल्य (१७) भ्रम (१८) कार्श्य (१९) भक्तद्वेष

१. दुष्प्रजातामयाः सति चतुःषष्टिरिति स्थितिः । योनिर्भ्रष्टा क्षत चैव विभ्रता मूत्रसङ्किनी ॥ ७॥

सशोफलाविणी चैव प्रसृता वेदनावती । पारवशुकटीशूलं हृदि शूलं विद्विचिका ॥ ८॥

प्लीहा महोदरत्वं च शाखवातोऽङ्गमर्दकः । शूक्ष्मेकौ हनुस्तम्भौ मन्दास्तम्भोऽपलातकः ।

मक्कल्लो विद्विषः शोफः प्रलापोन्मादकमलाः ॥ ९॥

दौर्बल्यं भ्रमलो कार्श्यं भक्तद्वेषोऽविपाचकः । ज्वरातिसारौ वैसर्पद्विद्विषा प्रवाहिका ॥ १०॥

हिक्का क्षमश्च कामश्च पाण्डुरुल्मश्च रक्तजः । अनाहाभ्रमनो चोषे चर्चोऽमृग्रहवपि ॥ ११॥

मुलरोमोऽधिरोगश्च प्रतिश्यायवातग्रहौ । राजयक्ष्माऽर्दितं कम्पः कर्पलावः प्रजापः ॥ १२॥

उष्णवातो ग्रहावाधस्तनोगोऽथ रोहिणी । वाताढीला वातगुल्मकभित्तविचिकः ॥ १३॥

इत्येते सूतिका रोगाश्चतुःषष्टिरहताः । तेभ्यः सर्वेभ्य एवार्ते रक्षितव्या कर्म त्विति ॥ १४॥ (का० सं० चि० १९)

२. योनिपृष्ठकटीभेदशाखावायुसुतरः । वाताढीला च गुल्मश्च हृदिशूलं प्रवाहिका ॥ ८॥

पुष्टिभूतसरोषं आभ्रान शूलमेव च । शूयते दुष्यते योनिर्योनिशूलं च दाहणम् ॥ ९॥

वेपथुश्छर्दनं मोहो मन्दास्तम्भो हनुग्रहः । ज्वरातिसारो वैसर्पो द्रुपामान्विचिकः ॥ १०॥

कटिपाथ्यश्च विस्फोट गान्धे चर्धिशिरोरुजा । हस्त्रोपाधिशिरोगश्च प्लीहा श्रवणशुकमले ॥ ११॥

एते चान्ये च बहवो दुष्प्रजाताशरीरजाः । व्याधयः संप्रकुच्यन्ति चिकित्सितमतः परम् ॥ १२॥ (का० सं० चि० ३)

- (३०) अतिवाक (३१) तुष्णा (३२) हिकका (३३) स्वास (३४) कास (३५) पाण्डु (३६) रक्तगुल्म (३७) आनाह (३८) मुखरोग (३९) प्रतिश्याय (३०) गालग्रह (३१) राजयक्ष्मा (३२) अर्दित (३३) कर्णस्तव (३४) प्रजागरण (३५) उष्णवात (३६) ग्रहबाधा (३७) स्तनरोग (३८) रोहिणी (३९) रक्तपित्त ।

Kāśyapa has described puerperal disorders at two places once in *dhṛupravāda-cikitsādhya* without giving exact number but numbering thirtyfive and again sixtyfour disorders in *sūtikopakramanīya adhyāya*. Twentyfive disorders have been enumerated at both the places while others differ. Thus total puerperal disorders described at both the places taken together become seventyfour which are given here under.

Disease entities described at both the places — (1) *Yonibheda* (vaginal tear), (2) *Yoniśoja*, (inflammation/edema of vagina), (3) *Yonivedanā* or *yoniśūla* (pain in vagina) (4) *Prśihasīla* (backache), (5) *Kaiśīla* (pain in lower back or sacral region), (6) *Hṛdiśīla* (cardialgia), (7) *Plihodara* (splenomegaly), (8) *Śāklāvāta* (hemiplegia), (9) *Hanugrāha* (lockjaw), (10) *Manya stambha* (neck rigidity), (11) *Śoja* or *śoṭha* (edema or inflammation) (12) *Kāmālā* (jaundice), (13) *Jvara* (fever), (14) *Aisāra* (diarrhoea), (15) *Visarpa* (erysipelas), (16) *Charāḍi* (vomiting), (17) *Pravāhikā* (dysentery), (18) *Adhmāna* (tympanties), (19) *Mūrarodha* (retention of urine), (20) *Malārodha* (constipation), (21) *Akṣiroga* (eye disorders), (22) *Kampa* or *vēpāhu* (tremors), (23) *Vātsiśīlā* (perineal swelling), (24) *Vāaguhna* (phantom tumour), (25) *Vicarcikā* (skin disorder).

Disease entities described only under *dhṛupravāda-cikitsādhya* — (1) *Astṛḍara* (bleeding per vaginum or menometrorrhagia), (2) *Śūla* (pain in abdomen) (3) *Yonidoṣa* (gynecological disorders), (4) *Moha* (unconsciousness), (5) *Dadru* (ring worm infection), (6) *Pāmā* (skin disorder), (7) *Kūṭibha* (skin disorder), (8) *Viśphoḍa* (blisters), (9) *Arḍha-śīroṇṇā* (hemisideria), (10) *Hṛdroga* (cardiac disorders).

Disease entities described only in *sūtikopakramanīya adhyāya* — (1) *Yonibhranśa* (uterovaginal prolapse), (2) *Yonikṣāta* (vaginal ulceration), (3) *Yonirāva* (vaginal discharge) (4) *Yoniprasuptā* (anaesthesia over vagina/vulva), (5) *Pāśvāśīla* (pain in flanks), (6) *Viśucikā* (pricking pain in abdomen associated with severe diarrhoea or cholera ?), (7) *Mahodara* (ascites), (8) *Āḡmanāda* (bodyache), (9) *Prakṣepāda* (convulsions), (10) *Apātānaka* (emprosthotonos), (11) *Makkalla* (spasmodic contraction of uterus after delivery), (12) *Vīradhi* (abscess), (13) *Prādāpa* (delirium) (14) *Mūrasaṅga* (suppression of urine), (15) *Ummāda* (insanity or psychotic condition associated with insomnia), (16) *Daurbalya* (weakness), (17) *Bhrama* (giddiness), (18) *Kāśya* (emaciation), (19) *Bhaktadweṣa* (anorexia), (20) *Avipāka* (indigestion), (21) *Tṛṣṇā* (thirst), (22) *Hikā* (hiccup), (23) *Śwāsa* (dyspnoea), (24) *Kāsa* (cough), (25) *Pāṇḍu* (anaemia), (26) *Raktaguhna* (molar pregnancy), (27) *Āndha* (flauence), (28) *Mukharoga* (diseases of oral cavity), (29) *Praiśyāya* (coryza), (30) *Galagrāha* (stiffness of inner components of throat), (31) *Rājayakṣmā* (tuberculosis), (32) *Arḍha* (facial paralysis), (33) *Karṇarāva* (otitis), (34) *Pravāgarāva* (gonorrhoea), (35) *Uṣṇāva* (gonorrhoea), (36) *Grahādhā* (acute infective disorders) (37) *Stānaroga* (diseases of breast), (38) *Rohiṇī* (diphtheria) and (39) *Raktapiṭta* (haemorrhagic diathesis).

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त वर्णित व्याधियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि काश्यप ने प्रसव के काल में उत्पन्न सूतिका के योनिक्षततिदि से लेकर तात्कालिक औसमर्गिक व्याधियों एवं अन्य सामान्य शारीरिक रोगों को इस सूची में अन्तर्भूत कर लिया है। त्वचागत एवं श्वसनसंस्थानगत व्याधियों का सूतिका से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भी सम्भवतः इसलिये समावेश किया हो कि शारीरिक दौर्बल्य, क्लान्ति आदि के कारण इस काल में इन व्याधियों के होने की सम्भावना अधिक होती हो या सूतिकाकाल में ये व्याधियाँ होने पर उनका विशेष प्रबन्ध करना पड़ता हो। अधिकतर व्याधियाँ प्रजननसंस्थान एवं पाचनसंस्थानगत हैं विभिन्न संस्थानों की दृष्टि से सभी ७४ व्याधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं—

१) प्रजननसंस्थानगत व्याधियाँ—

अ) योनि की स्थानिक व्याधियाँ यथा योनिभ्रंश, योनिक्षत, योनिभिन्नता, योनिशोफ, योनिप्रसृता एवं योनि वेदना आदि व्याधियाँ ।

ब) अन्य व्याधियाँ यथा योनिस्त्राव, योनिदोष, मक्कल्ल, विद्रधि, रक्तगुल्म एवं असुदर ।

२) पाचनसंस्थानगत व्याधियाँ—विस्त्रिका, प्लीहोदर, मूत्रोदर, कामला, भक्तद्वेष, अतिवाक, अर्दित, तुष्णा, प्रवाहिक, हिक्का, आनाह, आपान, वर्षाग्रह, वातगुल्म एवं उदरशूल, ये १६ व्याधियाँ ।

३) नाडीवहसंस्थान की विकृतिर्या—८ व्याधियाँ यथा शाखावात, प्रक्षेपक, हनुस्तम्भ या हनुग्रह, मन्दास्तम्भ, अपतानक, अर्दित, कम्प या वेपथु एवं गतग्रह ।

४) मूत्रवहसंस्थानगत व्याधियाँ—दो व्याधियाँ यथा मूत्रसङ्ग एवं मूत्रग्रह ।

५) श्वसनसंस्थानगत व्याधियाँ—पाँच व्याधियाँ यथा श्वास, कास, प्रतिश्याय, राजयक्ष्मा एवं रोहिणी ।

६) रक्तवहसंस्थानगत व्याधियाँ—पाण्डु, हृद्रोग एवं रक्तपित्त-गोन व्याधियाँ ।

७) मानसिक विकार—भ्रलाप, उन्माद, प्रजागरण एवं मोह-चार व्याधियाँ ।

८) त्वचागत विकार—विसर्प, विचर्चिक, दद्रु, पामा, क्कटिप एवं विस्फोट-६ विकार ।

९) शालाक्य व्याधियाँ—४ व्याधियाँ यथा मुखरोग, अक्षिरोग, कर्णस्त्राव एवं अधोशिरोशूल ।

१०) अन्य शूल—पाँच व्याधियाँ यथा पाश्वशूल, कटिशूल, पृष्ठशूल, हृदिशूल एवं अङ्गमर्द ।

११) सार्वदेहिक व्याधियाँ—शोफ, दौर्बल्य, भ्रम, काश्य, च्वर एवं ग्रहबाधा-६ व्याधियाँ ।

१२) अन्य—३ यथा स्तनरोग, वाताश्लीला, एवं उष्णवात ।

It appears that Kāśyapa has included in the list all the disorders starting from vaginal injuries during labour to general and infective disorders and also complications likely to arise due to puerperal diseases. Though disorders of skin and respiratory system are not directly related to puerperium, however, it is just possible that due to general debility during puerperium, the incidence of these might get increased, besides these need special management during puerperium. Most of the disorders are of reproductive and digestive systems. On the basis of specific systems, these seventy four diseases can be classified in following way—

1) Diseases of reproductive system

a) Local i. e. *bhranśa*, *kṣāta*, *bhinnatā*, *śoja*, *prasuptā* and *vedanā* of *yoni*, these, six disease.

b) Others i. e. *yonistṛava*, *yoniḥosa*, *makkalla*, *vidradhi*, *raktagūlma* and *asṛgḍara*, these six diseases.

ii) Diseases of digestive system—*Visickā*, *pīthodara*, *mahodara*, *kāmālā*, *bhaktiadvēṣa*, *avipāka*, *aśīṣara*, *chardi*, *tṛṣṇā*, *pravalikā*, *hikā*, *ānāha*, *ādhmāna*, *varacagṛaha*, *vāgūlma* and *udaraśīla* these sixteen disorders.

iii) Diseases of nervous system—*Śākhāvāta*, *praksepaka*, *hanustambha*, *manysāmbha*, *apānāka*, *ardha*, *kampa* or *vepālū* and *gūlagṛaha*, these eight disorders.

iv) Diseases of urinary system—*Mūrasaṅga* and *mūragṛaha*, these two disorders.

v) Diseases of respiratory system—*Śwāsa*, *pratiśyāya*, *rājyaśvāsa* and *rohinī*, these five diseases.

vi) Diseases of circulatory system—*Pāṇḍu*, *raktapiṭta* and *hṛdroga*, these three diseases.

vii) Psychological abnormalities—*Pralāpa*, *unmāda*, *prajāgṛāṇa* and *moha*, these four disorders.

viii) Cutaneous disorders—*Visarpa*, *vīcarcikā*, *dadrū*, *pāmā*, *kīṭhī* and *viśphoṭa*, these six disorders.

ix) Diseases of head or śālakya roga—*Mūharoga*, *akṣiroga*, *karnaśṛava* and *ardhaśīrośīla*, these four disorders.

x) Other pains—*Pāśvāśīla*, *kaiśīla*, *prāśīla*, *hṛdīśīla*, and *aṅgamāda*, these five disorders.

xi) General diseases—*Śofa*, *dauḥbalya*, *bhrama*, *kāṛṣya*, *jwara* and *grahabādhā*, these six disorders.

xii) Others—*Śīmanaroga*, *vāṭāśīla*, and *uṣṇavāta*, these three disorders.

पूर्ववर्णित सूतिकाव्याधियों के सामान्य निदान (General etiology of these puerperal disorders)

रात्रौ निर्मनात् रासात् सहस्रोत्तनादिपि । ईष्यशोकभयक्रोधानावेगविधारणात् ॥ ६ ॥

एतैश्चात्यैश्च नारीणां व्याधयः संभवन्ति हि । सूतिकानां दिवास्वप्नादजीर्णद्व्यशनादिपि ॥ ७ ॥

(का० सं० चि० ३)

रात्रि में बाहर निकलने, रास, सहसा ऊपर से गिरने, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, जाना वेग-विधारण, दिवास्वप्न, अजीर्ण में भोजन, अस्वप्न तथा अन्य कारणों से सूतिका स्त्री को व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । चरान्तर्गत महर्षि काश्यप ने दोष प्रकोपक कारणों का वर्णन किया है जो यहाँ भी मान्य है ।

Outing during night, terror or fright, sudden fall from height, jealousy, grief, fear, anger, suppression of various natural urges, day-sleeping, eating even in indigestion, eating before the digestion of previous meals and certain other factors are responsible for puerperal disorders. Etiology of vitiation of *doṣas* described under puerperal fever should be considered here also.

सूतिकाव्याधियों की सामान्य चिकित्सा (General treatment of puerperal disorders)

अ) त्रैवृतयोग—दोनों पञ्चमूल, भागी, मधुशिशु, शलाकरी, उशीर, चन्दन, श्वदंशू, मरयन्तिका, दोनों बला (बला एवं अतिबला), वसुक (ईश्वरमल्लिका या शिवमल्लिका), पाठा, पयस्या (संदिग्ध-दुग्धिका या अर्कपुष्पी), अमृता, वृषादती, सुगन्धा, पुनर्वा, मूर्वा, गुग्गुलु, मुस्ता, मोट तथा तिलक इनमें से जितने द्रव्यों की मूल मिल सके लेकर एकत्र कर लें । यह, कोल एवं कुलत्थ को (समान भाग में) मिलाकर तीन प्रस्थ ले लें एवं इनको आठ गुने जल में पकायें, अष्टमांश शेष रहने पर उतार कर भलीभाँति छान लें तथा उपर्युक्त पञ्चमूलादि (के चूर्ण) का एक मुष्टिक प्रमाण में (प्रत्येक औषधि का एक मुष्टिक प्रमाण) प्रक्षेप देकर रख लें । पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, हस्तिपिप्पली, चव्य, दोनों रजनी, शृङ्गवेर, वचा, अभया, कुष्ठ, रास्ना, अजमादा, विडङ्ग, मरिच, भद्रदार, एला, भाङ्गी तथा कुटज के बीज सभी (का कलक) एक एक कर्ष, सभी लवण (पौर्वो लवण) एक पल, तैल एक प्रस्थ, वसा एक प्रस्थ तथा इनसे दुगुना उपर्युक्त निमित्त क्वाथ एवं दुग्ध, दीधि तथा जल एक एक प्रस्थ, मातुलुङ्ग तथा आम्रपत्री का रस आधा प्रस्थ मिलाकर धीरे-धीरे पटु अग्नि में पाक करें तथा सिद्ध होने पर उतार लें । यह त्रैवृतयोग सूतिका के लिए अम्यङ्ग, पान एवं बस्तिकर्म के लिए अतिउत्तम है, इससे बात से उत्पन्न सभी विकार शान्त हो जाते हैं ।

आ) उपर्युक्त द्रव्यों के कलकों का क्वाथ बनाकर पिलाने से सभी सूतिका व्याधियाँ तीन दिन में ही शान्त हो जाती हैं ।

इ) दोनों पञ्चमूल, भाङ्गी, रास्ना, दोनों पुनर्वा (खेत एवं रक्त), शिशु तथा हंसपदी (आदि औषधियों का प्रयोग) सूतिकारोग में लाभप्रद है ।

a) **Traivṛta yoga**—Roots of available plants out of both the *pāñcamūlas*, *bhāṅgī*, *maṭhuśiṣṭu*, *śālākya*, *uśīra*, *candana*, *śvadaṇṣīra*, *madalyantika*, both the *balās*, *vasuka*, *pāṭhā*, *payasyā*, *amrā*, *vṛṣḍānā*, *sugandhā*, *pūnamavā*, *mūrvā*, *gṛghranakī*, *mustā*, *morāra* and *tibbaka* should be collected. Yava, kola and *kulathā* in equal quantity should be taken in the amount of three *prastha* and after making coarse powder should be boiled with eight times water. When 1/8th water remains, it should be separated from the

१. हे पञ्चमूल भागी च मधुशिशुः शलाकरी । उशीरं चन्दनं चैव श्वदंशू मरयन्तिका ॥ १३ ॥
हे कले वसुकः पाठा पयस्या क्षमृता तथा । वृषादती सुगन्धा च तथा कर्मा पुनर्वा ॥ १४ ॥
मूर्वा गुग्गुलु मुस्ता मोटसिलकस्तथा । इत्येतासां तु मूलानि यथातापं समानयेत् ॥ १५ ॥
यवकोलकुलत्थानां त्रयः प्रस्थाः समस्ततः । एलायष्टगुणे तोये पाचयेद्विपुलतमः ॥ १६ ॥
अष्टमांशस्थितं तं तु पुरिष्टं निधारयेत् । तत्रावापमिदं दद्यान्मुष्टिकाव्याधौ यानि तु ॥ १७ ॥
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली । चव्यं हे रजनी चैव शृङ्गवेरं वचाऽभया ॥ १८ ॥
कुष्ठं रास्नाऽजमादाश्च विडङ्गं मरिचानि च । भद्रदारश्चैला च भाङ्गीकुटजजटुलाः ॥ १९ ॥
एतेषां कर्षिका भागा लवणानां पलं भवेत् । तैलप्रस्थं वसाप्रस्थं निष्कवाणो द्विगुणं भवेत् ॥ २० ॥
क्षीरप्रस्थो दीधिप्रस्थो जलप्रस्थस्तथैव च । मातुलुङ्गापत्रीणां रसस्यार्धमात्रेणैव ॥ २१ ॥
येनैर्मूर्ध्निना सिद्धमधैमवातारयेत् । अम्यङ्गनेषु पानेषु बस्तिकर्मणि चोत्तमः ॥ २२ ॥
येन वातसमुत्थानाः सूतिकानामुपद्रवाः । सर्वेषां शपनं श्वेदनेनैवमुत्तमम् ॥ २३ ॥
एतेषामेव सर्वेषां कलकं निष्कवाणं पाययेत् । यः कश्चिद् सूतिकाव्याधिसत् विज्ञानेन साधयेत् ॥ २४ ॥
हे पञ्चमूल्यो भागी च रास्ना हे च पुनर्वि । शिशुहंसपदी..... ॥ (का० सं० चि० ३)

fire, cooled and strained properly. Now in this decoction powder of above mentioned drugs each in one *muslika* quantity should be mixed. Paste of *pippali*, *pippalimūla*, *citraka*, *hastipippli*, *carya*, both *rajānās*, *śrīṅgābera*, *vacā*, *abhyā*, *kuṣṭha*, *rāśnā*, *gajamūla*, *vidāṅga*, *marica*, *bhadrādarū*, *elā*, *bhāṅgū* and *kuṭaja* seed each one *kaṣṭa*, all the five salts together one *pala*, oil one *prastha*, fat one *prastha*, decoction (described above) in double quantity i. e. two *prastha*, milk, curd and water each one *prastha*, juice of *māṇūṅga* and *āmrāpeṣṭi* (pulp of mango) both together $\frac{1}{2}$ *prastha* should be cooked over low fire, when it is properly prepared it should be removed from the fire. This preparation known as *trairāyoga* is very good for the puerperal woman to be used in the form of massage, tisane and enema. This cures all the disorders arising due to vitiation of *vāta*.

b) Decoction prepared with pastes of all the herbs of *trairāyoga* cures all puerperal disorders within three days.

c) Use of both the *pañcamūla*, *bhāṅgū*, *rāśnā*, both *punarnavā*, *śīṅgu* and *hanṣapadi* is beneficial in puerperal disorders.

विशिष्ट सूतिकाव्यापद (Specific puerperal disorders)

१) सूतिकारोग (Sūtikā roga)

महर्षि सुश्रुत ने सूत्ररूप में लिखा है कि अप्रज्वाल की ज्यारिद व्याधियों की उत्पत्तयेक वर्णित ज्यारिद के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। टीकाकार डक्कण ने अप्रज्वाला से अकालप्रसूता ग्रहण करते हुए लिखा है कि ज्यारिद व्याधियों की उत्पत्तयेक वर्णित सामान्य ज्यारिद-सदृश चिकित्सा के ही साथ वहाँ पर वर्णित अन्य सभी व्याधियों की भी उत्पत्ति अप्रज्वाला में मानी जानी चाहिए तथा उत्तरकाल अर्थात् प्रसव के पश्चात् होने वाली अपतानक आदि व्याधियों की भी चिकित्सास्थान में वर्णित चिकित्सा ही करनी चाहिए। अप्रज्वाला की सामान्य ज्यारिद के साथ विशिष्ट अपतानक आदि होते हैं जिनको सामान्य-वर्णित चिकित्सा ही करनी चाहिए।

महर्षि शार्ङ्गधर ने भी लिखा है कि सूतिका की ज्यारिद जो व्याधियाँ हैं उनको दोष एवं बल के आधार पर चिकित्सा करें, अर्थात् सामान्य व्यक्ति को होने वाली सभी व्याधियाँ सूतिका को हो सकती हैं तथा उनकी सामान्य रूप से ही दोषादि के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए।

महर्षि सुश्रुत ने सूतिका को अर्द्धित^१ व्याधि तथा महर्षि चरक एवं वाग्भट ने विषम-प्रसूति से अर्श हो जाने का उल्लेख किया है।^२ निम्न शोध के कारणों में भी विषम-प्रसूति का उल्लेख है।^३ महर्षि कारश्य ने दुष्प्रज्वाला, कष्टप्रसवा अथवा सामान्यप्रसवा को भी शोध होने का उल्लेख किया है (शोध निदानान्तर्गत)।

१. अप्रज्वालरोगाश्च चिकित्सेदुत्तराद् भिषक् ॥ ३२॥

(अप्रज्वाला अकालप्रसूता, तस्या रोगान् ज्यारिदकान् । तानुत्तरादुत्पत्तयेकज्यारिदचिकित्सत्वात् । रोगांश्चेति चकार उत्तरतयादिचर्य योजनीयः । तेनाप्रज्वालरोगानुत्तरादुत्पत्तयेकज्यारिदत्वे, चकारादप्रतानकादीन् संहितोक्तेन विधिना चिकित्सेदित्यर्थः । अन्ये तु उत्तरान् इति पठन्ति, उत्तरकालभाविनोऽपतानकादीन् भिषक् चिकित्सेत्, स्त्रीश्चिकित्सतेः इति:

शेषः-डक्कण) (सु० सं० ३८/३२ व डक्कण टीका)

२.तथा ये सूतिकावाः ॥ १८४॥ ज्यारिदव्याधित्वासे यथातोषं यथाबलम् ॥ १८५॥ (शा० सं० पूर्व० ७)

३. सु० सं० नि० १६/८ से ७२

४. च० सं० चि० १४/१; अ० सं० नि० ७/१०

५. च० सं० सू० १८/६; च० सं० चि० १२/६; पा० प्र० चि० ४२/२

६. का० सं० चि० १७/५, ६

माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगतत्त्वाकर पुस्तकों में सूतिकारोग नाम से एक व्याधि का वर्णन है। आचार्यों ने ग्रन्थम में एकवचन (सूतिकारोग) का प्रयोग कर तथा विशिष्ट लक्षणों को लिखकर तत्पश्चात् बहुवचन (सूतिकारोगानां ते रोगाः) का प्रयोग किया है जिससे यह अर्थ निकलता है कि ये सभी व्याधियाँ एक ही तीव्र व्याधि के लक्षण स्वरूप या एक साथ भी हो सकती हैं यथा अङ्गमर्द, ज्यारिदसादि एक साथ अथवा पृथक् पृथक् स्वतन्त्र व्याधि यथा ज्वर, अतिसार, शोथ आदि के रूप में भी उत्पन्न हो सकती हैं।

Suśruta says that fever etc. disorders developing in a *apraprajā* (having premature or abnormal delivery) should be treated on the lines of general fever etc. as described in *utāraṇāntra*. Dāhaṇa has clarified that all the diseases described in *utāraṇāntra* can afflict a puerperal woman and should be treated accordingly. Other diseases like *apātānaka* (tetanus) etc. developing after delivery should be managed with the procedure described in *cikrīvāsthāna* (chapter dealing with the treatment). Sārngadhara opines that diseases of puerperal woman should be treated on the basis of specific *dosa* and their amount of vitiation. Suśruta has described *ardīa* (facial paralysis) to a *sūtikā*. Abnormal or difficult labour is said to be one of the causative factor for *arśa* (piles) and *nija śotha* (endogenous edema).

Mādhavanidāna, Bhāvaprakāśa and Yogaratnākara etc. books have described a disease named *sūtikāroga*. After initial use of singular number, in subsequent description plural number has been used, which indicates that all fever, bodyache etc. described under clinical features may develop as a complication of one disease or else independently as individual disorders.

अ) सूतिकारोग निदान (Causes of sūtikāroga)

मिथ्या उपचार (अनुचित आचरण या वायु आदि का सेवन), संक्रोश (दोष जिस प्रकार क्रोश पाते हैं अर्थात् दोषोत्पादक आहार-विहार), विषम तथा अजीर्ण भोजन करने से जो सूतिका रोग उत्पन्न होते हैं वे दारुण होते हैं^{१,२,३}।

Sūtikāroga developing due to use of direct air, dietetics and mode of life likely to aggravate *dosas*, incompatible food and indigestion are very serious.

आ) सूतिकारोग-लक्षण (Clinical features of sūtikā roga)

अङ्गमर्द, ज्वर, कम्प^{१,२} या कास^३, पिपासा, गुरग्रात्रता, शोथ, शूल तथा अतिसार आदि सूतिकारोग के लक्षण हैं^{१,२,३}।

ज्वर, अतिसार, शोथ, शूल, आनाह, बल-क्षय, तन्मा, अरति तथा प्रसेक आदि कफवृत्तज व्याधियाँ (सूतिका के) अनि, बल-एवं मांस के क्षीण होने के कारण कच्छुसाध्य होती हैं। ये सभी (व्याधियाँ) सूतिकारोग के नाम से जानी जाती हैं तथा ये उपद्रव रूप में भी हो सकती हैं^{१,२,३}।

१. मिथ्योपचारत् संक्रोशाद्विषमजीर्णभोजनात् । सूतिकायाश्च ये रोगा जन्वन्ते दारुणास्तु ते ॥ (मा० नि० ६५/२)

२. मिथ्योपचारत् सूतिकायास्तु दारुणाश्च ते ॥ (मा० नि० सदृश) (पा० प्र० चि० ७०/१४७)

३. यो० १० स्त्रीरोग चि० (पा० प्र० सदृश)

४. (अ) मिथ्योपचारत् = अनुचितआचरणत्, प्रवृत्तादि सेवनात् । संक्रोशाद् = संक्रोशयन्ते दोषा अनेनेति संक्रोशो = दोषजनकमात्रं तस्मात् । (पा० प्र० चि० ७०/१४७ की टीका)

(आ) संक्रोशयन्ते उत्क्रिस्तयन्ते दोषोऽनेनेति संक्रोशो दोषजनकमत्रम् । (मा० नि० ६५/२ की मधुकोष व्याख्या)

नोट - लक्षण के सन्दर्भ पृष्ठ ५६६ में देखें।

मधुकोष व्याख्या में लिखा है कि ज्वराग्निसार आदि का पुनः उत्प्रेषण (दो बार) रोगों की अधिकता, कुच्छसाध्या तथा उपद्रव रूप में भी उत्पत्ति होने के कारण किया गया है। तद्विधि के साथ ही ज्वराग्निसार भी कफवातज तथा कुच्छसाध्या होते हैं। उपर्युक्त सभी व्याधियाँ सूतिका में होने अर्थात् आश्रित एवं आश्रय में भेद न होने के कारण सूतिकारोग के नाम से कही गई हैं तथा ये सभी ज्वरज व्याधि होने के साथ ही उपद्रवरूप में भी हो सकती हैं।^१

Bodyache, fever, tremors or cough, thirst, heaviness of body, edema, pain in abdomen and diarrhoea are the clinical features.

Due to loss of digestive/ metabolic fire strength and musculature, these fever, diarrhoea, edema, pain in abdomen, tympanites, loss of energy, drowsiness, anorexia and excessive salivation etc. *kaphavāta* disorders are difficult to be cured.

All these diseases can develop either together at a time, or separately or as complications. Since all these afflict the puerperal woman hence are termed as *sūkāroga*.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सूतिकारोगों में शोथ का उत्प्रेषण आया है सामान्य शोथ के वर्णन में निज शोथ की उत्पत्ति के कारणभूत गर्भात होना, प्रजाता या सूतिका के द्वारा उचित उपचार का पालन न करना तथा कष्ट से प्रसव होना आदि भी वर्णित हैं। शोथ एकाङ्ग या सर्वाङ्ग हो सकता है। सूतिका के एकाङ्गज शोथ से आधुनिक पुस्तकों में वर्णित स्वेत पादशोफ का भी ग्रहण कर सकते हैं।

Edema (*śotha*) is mentioned as one of the disorders. While describing *śotha* as a disease, amongst *nijā* (endogenous) causes the abortion, improper management of puerperium and difficult or abnormal labour have been included. Edema may be generalised (*svavāṅga*) or localised such as of one extremity or leg (*ekavāṅga*), this leg edema can be equated with whiteleg or phlegmasia-alba-dolens.

१. अङ्गनर्तो ज्वरः कम्पः पित्तास गुरुतात्रता । शोथः शूलतिसरो च सूतिकारोगलक्षणम् ॥ १॥
ज्वरातीसारशोथश्च शूलानाहवन्तश्चः । तन्नाशचिप्रेक्षकाः कफवातमयोद्भवाः ॥ ३॥
कुच्छसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसवन्तानि । ते सर्वे सूतिकानाम् रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४॥ (भा० नि० ६५)
२. अङ्गनर्तो ज्वरः कासः । लक्षणम् ॥ १४८॥ ज्वरः प्रसेकाद्या वातरोजसमुद्भवाः ॥ १४९॥
कुच्छः बलाश्रिताः । उपद्रवाः ॥ १५०॥ (भा० नि० सदृश) (भा० प्र० वि० ७०)
३. अङ्गनर्तो ज्वरः कम्पः उपद्रवाः ॥ (भा० प्र० सदृश) (यो० २०, स्त्रीरोगे वि०)
४. ज्वरातिसारादिनाङ्गमदीदृशः पृथक् पुनरुपपन्नं रोगाधिक्यं कुच्छन्मुपपद्रवत् च व्यापयिष्युः । कफवातजे विकारौ सति येणामुद्रस्तं कफवातामयोद्भवा ज्वरातीसारदयः कुच्छसाध्या इत्यर्थः । ते सर्वे सूतिकानामेति ते ज्वरातीसारदयः सर्वे सूतिकाभवत्वेनाश्रयाश्रितयोरपेक्षयात् सूतिकानामोच्यते; ते चाप्युपद्रवाः ते उपद्रवाश्च भवन्ति उक्तानां रोगणामन्यतमं प्रधानीकृत्य ॥ (भा० नि० ६५/३, ४ को मधुकोष व्या०)
५. (अ) निवाः पुनः गर्भसमीडनादाभ्यामप्रपतन् प्रजातानां च भिद्योपचारात् ।
(आ) विषमाग्रसूतिः निजस्य हेतुः ।
(च० सं० वि० १२/६; भा० नि० ३६/४; भा० प्र० वि० ४२/२ तथा यो० २० शोथनिदान, विषमाग्रसूतिः
अकालगर्भापतनादिकाः चक्राणि तथा मधुकोष दोषों की व्याख्या)

(च० सं० सू० १८/६)

इ) सूतिकारोग-चिकित्सा (Treatment of sūkā roga)

चिकित्सा-सिद्धान्त (Principles of treatment)

सूतिकारोग को शान्त करने के लिए चायुनाशक^१ अथवा दोष एवं बलाग्निसार चिकित्सा करनी चाहिए^२ ।

Treatment capable of suppressing *agni* or else on the basis of aggravation of *doshas* and strength (of the woman) should be done.

औषधियाँ (Drugs)

क्वाथ (Decoctions)

- १) दशमूल के उष्ण क्वाथ को घृत मिलाकर पिलाना चाहिए^{३,४} ।
- २) अमृता, नागर, सहचर, भद्र, उत्कट, पंचमूल तथा जलद^५ एवं जल^६ (वातक) के क्वाथ को शीतल कर मधु मिला कर पान सूतिका-व्याधियों का तत्काल ही शमन कर देता है^{३,४} ।
- ३) देवदाब्धि क्वाथ :- देवदारु, वचा, कुष्ठ, पिप्पली, विशभेषज, भूनिम्ब, कटफल, मुस्ता, तिका, धान्य, हरीतकी, गज, कुण्ठा, दुःस्पर्शा, गोक्षुर, धन्व्यास, बृहती, अतिविषा, छिन्ना, कर्कटशृङ्गी तथा कृष्णजीरक को समान भाग लेकर अष्टांशवशेष क्वाथ बनाकर सैन्यव एवं तामट मिलाकर स्त्री को पीने को दें। इस क्वाथ के पीने से शूल, कास, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कम्प, सिर-शूल, प्रताप, तुषणा, दाह, तन्द्रा एवं अतिसार आदि से युक्त वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों से उत्पन्न सूतिकारोग नष्ट होते हैं। इनकी यह श्रेष्ठ औषधि है^{३,४,५} ।
- ४) निगुण्डी, लशुन तथा नागर का क्वाथ बना, कपोल क्वाथ में कण-चूर्ण मिलाकर पीने से कफवातज प्रकोप से उत्पन्न सूतिकाव्यापत् नष्ट होते हैं^४ ।
- ५) सहचर, कुलत्थ, पुष्करमूल, दालिपिशा, दारु तथा वेतस के क्वाथ को हिंगु एवं लवण मिलाकर पीने से सूतिका के शूल तथा ज्वर का नाश होता है^४ ।
- ६) पञ्चमूल के क्वाथ में तप्त लौह बुझाकर अथवा सुरा मिलाकर सूतिकारोग नष्ट करने के लिए पिलाना चाहिए^४ ।

१. सूतिकागोशान्त्यर्थं कुर्वाद्वातहर्तं क्रियम् । (भा० प्र० वि० ७०/१५९ एवं यो० २० स्त्रीरोगे वि०)
२. शो० सं० पूर्व० ७/१८५ (पृष्ठ ५६४)
३. दशमूलकृतं क्वाथं कोष्णं दद्याद् घृताञ्चितम् ॥ १५९॥
अमृतानागरसहचरभद्रोत्कटपञ्चमूलक जलदम् । नृत्तशीतं मधुयुक्तं शमयत्यधरेण सूतिकाऽऽतङ्कम् ॥ १५२॥
देवदाब्धि क्वाथ :-
देवदारु वचा कुष्ठं पिप्पली विशभेषजम् । भूनिम्बः कटफलं मुस्तं तिका धान्यहरीतकी ॥ १५३॥
गजकुण्ठा सद्दुःस्पर्शा गोक्षुरधन्व्यासकः । बृहतीतिविषा छिन्ना कर्कटः कृष्णजीरकः ॥ १५४॥
समभागान्चितैः सिन्धुगामसंयुतम् । क्वाथमप्यवशेषं तु प्रसृतं पायदेव स्थियम् ॥ १५५॥
शूलकासज्वरश्वासमूर्च्छाकम्पशरीरतिथिः । युक्तं प्रलापुड्बलहन्त्राऽतीसारवातिभिः ॥ १५६॥
निहितं सूतिकारोगं वातपित्तकफोद्भवम् । क्वाथो देवदाब्धिः सूतायाः परमौषधम् ॥ १५७॥

(भा० प्र० वि० ७०)

४. दशमूल घृताञ्चितम् । अमृता पञ्चमूलजलदञ्चितम् । सूतिकातङ्कम् ॥
देवदारु धान्यं हरीतकी । गजकुण्ठा च । कर्कटं कृष्णजीरकम् ॥
..... सिन्धुगामट । । सूतायाः परमौषधम् ॥ (भा० प्र० वि० ७० सदृश) (यो० २० स्त्रीरोगे वि०)

संयोजितो दलितव्या कण्ठा कपोलो, निगुण्डकातशुननागरजः क्वाथः ।
पीतो निहितं कफमारुतकोपजान्, सूतामयं सकलमेव सुदुस्तं च ॥

क्रमशः ।

For oral administration—

- i) Hot decoction of *dasāmīla* mixed with *ghrita*.
- ii) Cooled decoction of *amrīṭa*, *nāgara*, *śahacāra*, *bladhra*, *utkaṭa*, *pañcamūla*, *jālada* and *jala* mixed with honey.

iii) *Devadārvyādi decoction* :— Decoction prepared with equal quantity of *devadāru*, *vacā*, *kuṣṭha*, *pippalī*, *viśvabhesajā*, *bhūmibā*, *kaiphalā*, *mustā*, *tiktā*, *dhānya*, *haritāki*, *gūjā*, *kṛṣṇā*, *dhūlparśā*, *gokṣura*, *dhanvayāsa*, *brhātī*, *ativīṣā*, *chinmā*, *karṭhāśīrṣṭī* and *kṛṣṇajīraka* mixed with rock salt and *rāmaṇḍa* (*hingū*) should be given. Use of this, cures *śūlīkāroga* produced by vitiation of all the three *doṣas* and associated with pain, cough, fever, dyspnoea, unconsciousness, tremors, headache, delirium, thirst, burning sensation, drowsiness and diarrhoea.

iv) Use of lukewarm decoction of *nirguṇḍī*, *lāsūna* and *nāgara* mixed with powdered *kaṇā* relieves puerperal disorders caused due to *vāta* with *kaṭha*.

v) Fever and pain of puerperal disorders are cured by use of decoction of *śahacāra*, *kalathā*, *paṣkaramūla*, *dāruṇīṣā*, *dāru* and *vetasa* mixed with *hingū* and salt.

vi) Decoction of *pañcamūla* either after dipping in it heated iron or after mixing wine.

पाक (Pāka or cooked medicines)

(१) पञ्चजीरक पाक (Pañcājīrakā pāka)

जीरा, स्थूलजीरा, शतपुष्पाद्वय (सौंफ एवं सोया), यवानी, अजमोदा, धान्यक, मेथिका, शुण्ठी, कुष्माण्ण, कणामूल, चित्रक, हनुष एवं बदरी, गज (गजपिप्पली) तथा कुल (पटोल) या विदारीकन्द एवं कुछ^१ तथा कपित्थक इन सब का चूर्ण एक एक पल, गुड़ सौ पल, दुग्ध दो प्रस्थ तथा घी एक कुडव लेकर पाक करें, यह पञ्चजीरक पाक है। यह प्रसूता स्त्रियों के लिए श्रेयस्कर्म है। यह सूतिकारोग, योनिरोग, ज्वर, क्षय, कास, श्वस, पाण्डुरोग, कार्श्य तथा वातविकार में लाभदायक है^{१,२}।

..... क्रमशः

सहचक्रुलत्पुष्कदारानिशादलवतसक्वाथः । पीतः सहितुलवणः शमयति शूलज्वरौ सूत्र्याः ॥

पञ्चमूलस्य वा क्वाथं तालहेन संगतम् । सूतिकारोगनाशाय पिबेन्न तद्युतं सुप्तम् ॥ (यो० २० स्त्रीरोगे चि०)

५. देवदार ॥ ४९ ॥ कट्फलं मुराभूनिच्यतिकाध्याया हरीतकी । धन्यासकम् ॥ ५० ॥

वृहत्सतिविषा च कुष्माण्णकम् । क्वाथमष्टावशेषं कामाशिरसिभिन् ॥ ५१ ॥ (पा० प्र० चि० ७० सदृश) (शा० सं० मध्य० २/४९ से ५१)

१. जीरकं स्थूलजीरकं शतपुष्पाद्वयं तथा । यवानी चाजमोदा च धान्यकं मेथिकाशपि च ॥ १५८ ॥

शुण्ठी कुष्माण्ण कणामूलं चित्रकं हनुषाशपि च । बदरीगजपुष्पाञ्च कुलं कपित्थकं तथा ॥ १५९ ॥

एतानि पचमात्राणि गुडं पलशतं मतम् । क्षीरपश्याद्वयं दद्यात्सर्पिषः कुडवं तथा ॥ १६० ॥

पञ्चजीरकपाकोऽयं प्रसूतानां प्रशान्तये । युज्यते सूतिकारोगे योनिरोगे च्चे क्षये ॥ १६१ ॥

कारसे श्वसे पाण्डुरोगे कार्श्ये वातामयेषु च ॥ १६२ ॥ (पा० प्र० चि० ७०)

२. जीरकं मेथिकाशपि च ॥ शुण्ठी विदारीफलचूर्णं तु कुडवं ॥ एतानि कुडवं तथा ॥ पञ्चजीरक वातामयेषु च ॥ (पा० प्र० सदृश) (यो० २० स्त्रीरोगे चि०)

(विदारीफल के स्थान में विदारीकन्द पाठ युक्तिसंगत प्रतीत होता है क्योंकि विदारी का पल नहीं होता तथा फल अथवा मदनफल का प्रयोग अजमोदीय है—पि० ब्र० शर्मा)

Powdered *jīrā*, *śhūlā-jīrā*, *śatapuṣpādāvayā*, *yavānī*, *ajamodā*, *dhānyaka*, *methikā*, *śuṇṭhī*, *kṛṣṇā*, *kaṇāmūla*, *citrakā*, *hapṣa* and *badarī*, *gūjā* with *kula* (*paṭola*) or *vidārīkanda* with *kuṣṭhā* along with *kampillaka* each one *pala*, jaggery 100 *pala*, milk two *prastha* and *ghrita* one *kuḍava* should be cooked together. This *pañcājīrakā pāka* is beneficial for puerperal woman in general and *śūlīkāroga*, *yoni-rōga* (gynec disorder), fever, *kṣaya* (tuberculosis), cough, dyspnoea, anaemia, emaciation and disorders of *vāta* in particular.

(२) नागरखण्ड (Nāgarakhanda)

घृत २ पल^१ या २ अञ्जली^२, दुग्ध दो प्रस्थ, शर्करा पचास पल तथा नागर-चूर्ण आधा प्रस्थ लेकर गुड़पाक-विधि से पाक करें, इसमें धान्यक तीन पल, मिश्रि गौच पल तथा कृमिपि, अजानि, जीरा, व्योष, अजमोद, दल, उरोन्मसुमन, लवङ्ग एवं द्राविडी का एक एक पल चूर्ण डाल दें इस प्रकार बनाए हुए पाक को नागरखण्ड संज्ञा दी गई है, यह सूतिकारोग तथा तुष्णा, जर्द, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, कास, प्लीहा व्याधि तथा कृमिरोग का नाश करता है मन्दानि को तीव्र करता है^{१,२}।

Ghrita two *pala* or two *añjālī*, milk two *prastha*, sugar fifty *pala* and powdered *nāgara* half *prastha* should be cooked together. Now in this, powdered *dhānyaka* three *pala*, *mīṣī* five *pala* and *kṛmīpī*, *ajajī*, *jīrā*, *vyoṣa*, *ambhoda*, *dala*, *urugendrasumana*, *lavak* and *drāviḍī* each one *pala* should be mixed. This preparation is known as *nāgarakhanda* and cures *śūlīkārōga*, thirst, vomiting, fever, burning sensation, *śōṣa* (emaciation), dyspnoea, cough, splenic disorders and parasites, besides it also increases appetite.

३) अन्य नागरखण्ड या सौभाग्यशुण्ठी (Other nāgarakhanda or saubhāgyashuṇṭhī)

नागर को टुकड़े टुकड़े काट कर एक प्रस्थ लें, इसमें दो आहक बकरी का दूध डालकर धीमी धीमी आँच में पकावे। दुग्ध के घन या गाढ़े हो जाने पर शुण्ठी के टुकड़ों को निकालकर घूप में सुखा कर अत्यन्त महीन पीस लें। एक मानी (आधा प्रस्थ) घृत (गौ) लेकर उपर्युक्त दुग्ध को पुनः पकावे, जब वह दुग्ध पिण्ड रूप में हो जाय तब उसमें यह शुण्ठी चूर्ण डाल दें। अब इसमें चतुर्जाल, गुग्गु, वेल्ग, धान्यक, जीरकद्वय, मिश्रि, आकल्लक, शुण्ठी, लवंग, शतावरी, तालमूली, त्रिकटु, कपिकच्छू, षट्कटु, जातीफल, जातिपत्री, मृङ्गाटक, वृद्धदारक, त्रिवृत्, पद्मबीज, त्रिफला, बलात्रय/बला, अतिबला, नागबला, जल, सेव्य, वाजिनाथा, चन्दन, अगर, कारवी, कङ्काल, अजगरथा, ब्राक्षा, आक्षोट, वारिज, अजमोद, बादाम, नारिकेल एवं कपूर तथा अश्रक, लोह, वंग, ताम्र (रसम्), शिलाजतु तथा स्वर्णमाक्षिक (रसम्) प्रत्येक का एक एक कर्ष लेकर चूर्ण करके हाथ से कसकर मलकर मिला दें। तत्पश्चात् एक तुला (सौ पल) शक्कर लेकर पाक करें,

१. आचवं स्यात्तलपुममत्र परसः प्रस्थद्वयं खाडतः । पञ्चाशत्तलमत्र चूर्णितमथो प्रक्षिप्यते नागम् ॥

प्रस्थार्धं गुडवद्विषाख्य विधिना मुष्टिद्वयं धान्यकान्मिश्रयाः पञ्चपलं पलं क्रमिपिरोः साजिजीरीयादपि ॥ १६३ ॥

व्योषाम्मोददलोरोरुसुमनस्त्यद्राविडीनां पलं । पक्वं नागरखण्डसङ्कमिदं तत्सूतिकारोगाहर्त् ॥

वृद्धद्विज्ज्वरदाहशोषशमनं सक्षसकासापहं । प्लीहाव्याधिविनाशनं कृमिहरं मन्दानिंसदीपनम् ॥ १६४ ॥

(पा० प्र० चि० ७०)

२. आजस्यञ्जलिः साजिजीरीयादपि ॥

व्योष सुमनः सद्राविडीनां पलं । पक्वं सौभाग्यदं योक्तव्यम् ॥

वृद्ध मन्दानिंसदीपनम् । (पा० प्र० सदृश) (यो० २० स्त्रीरोगे चि०)

इसे नगराखण्ड कहते हैं इसे बल के अनुसार प्रातः सायं औषधि के रूप में खाए। यह स्त्रियों के लिए अत्यधिक श्रेयस्कृत है, इसके सेवन में पथ्यापथ्य का विचार नहीं करना पड़ता। यह क्षय, पाण्डु, ज्वर, कास, श्वास, मन्दाग्नि, संग्रहणी, रक्ताल्प, प्रदर, सोमरोग, दुग्धक्षय, मूत्रकुच्छ, कामला, गलाहट, सभी वातपित्त-विकार तथा सूतिका की वात-व्याधियों में प्रशस्त है, इसमें कोई संशय नहीं है, इस उत्तम योग को अग्निनीकुमारों ने पहिले ही कहा है यह स्त्रियों को सौभाग्य एवं पुत्रप्रद शुद्धीकरक है^१।

iii) One *prastha* cut pieces of *nāgara* should be boiled with two *āḍhaka* of goat's milk over low fire. When the milk gets condensed, the pieces of *nāgara* should be removed, powdered fine after drying in sun. Left over milk should be reboiled with ½ *prastha* cow's *ghrita*, when milk becomes solid, the powdered *sunthi* should be mixed in it. Now in this mixture powdered *caturjāta*, *tugā*, *vella*, *dhānyaka*, *jīrakadhūya*, *miṣi*, *ākallaka*, *sunthi*, *lavāṅga*, *śatāwarā*, *īlāmālā*, *trikāyā*, *kāpikācchā*, *śaṭkāyā*, *jāitphala*, *jāitpatrā*, *śṛṅgāḍaka*, *vīrdhāḍāraka*, *trivṛja*, *padmābhīja*, *triphālā*, *balāraya*, *jala*, *sevyā*, *vājigandhā*, *candana*, *agurā*, *kāravī*, *kāhikola*, *ajagandhā*, *drākṣā*, *ākṣotā*, *vāyijā*, *glānoda*, *bādāma*, *nārikela*, *kapūrā*, and *bhasmas* of *abhṛaka*, *loha*, *vāṅga*, *tāmra* and *swarnamāṅkṣika* with *śīlājatu* each *kapūrā*, and *bhasmas* of *abhṛaka*, *loha*, *vāṅga*, *tāmra* and *swarnamāṅkṣika* with *śīlājatu* each one *karṣa* should be mixed by forcibly mashing with hand. This mixture should be cooked with one *ulā* (100 *pala*) sugar by standard procedure. This preparation termed as *nāgarakhaṇḍa* should be taken as medicine both the times i.e. morning and evening from consideration of its strength. It is beneficial specially to the women and is free from consideration of congenial or non-congenial diet. It is beneficial in tuberculosis, anaemia, fever, cough, dyspnoea, *mandāgni* (weak digestive fire), *saṅgrahāṇī* (sprue syndrome), *raktaḡulma* (molar pregnancy), *pradara* (leucorrhoea and menorrhagia), *sonmaroga* (polyuria due to A.D.H. abnormality), loss of milk secretion, dysuria, jaundice, neck-rigidity and all *pitta*, *vātipitta* and puerperal woman's *vāta* disorders. In these conditions effect is definite, besides it also provides fortune and male child to the woman.

१. नगरं कणशः कृत्वा प्रसमात्रं भिषक्तः। अजादुग्धाण्डकद्वे च विषयेमन्दवह्निना ॥
घनीभूते तु पयसि तन्माच्छुषीं समुद्धरेत्। अतिरूक्षं विनिष्य शोषयेदात्रे खरे ॥
भूतमार्गं समवाप्य तदुपुं तु पुनः पक्वेत्। वातपित्तवृत्तमायाति ततस्तत्र विनिक्षेपेत् ॥
चातुर्जतं तुगा वेल्तं धान्यकं जीरकद्वयम्। मिश्रमाकल्लकं शुण्ठीं त्वक्कं च शतावरीम् ॥
तालमूलीं विकटुकं कपिकच्छं च षट्कटुं। जातीफलं जातिपत्रीं शुङ्गदं वृद्धदारकम् ॥
त्रिवर्गं पद्मवर्गं च त्रिफलीं च बलात्रयम्। जतं सेव्यं वाजिगन्धचन्दनामकावरीः ॥
काङ्क्षालमगन्धार्वा च द्राक्षामाक्षोटवारीजे। अजमोदं च बालाम् नागिकेतलं तथा ॥
कर्पूरमकं लोहं चक्कं ताम्रं शिलाजतुं। स्वर्णमार्शिकमयेतलत्रलेकं कर्मात्रकम् ॥
चूर्णीकृत्य क्षिपेत्तत्र पाणिप्यां मर्दयेद्दृढम्। ततः खण्डतुलां पक्त्वा तथा तच्च क्रियां चरेत् ॥
खण्डनागकं नाम्ना धैर्यव्यामिदुत्तमम्। यथावत्पिदं खोदयताः सार्यं च भेषजम् ॥
स्त्रीणामतिरिक्तं नात्र पथ्यापथ्याविचारणम्। क्षये पाण्डौ च्चे कासे श्वासे मन्दाग्ने तथा ॥
संग्रहण्यां रक्ताल्पे प्रदरे सोमरोगे। दुग्धक्षये मूत्रकुच्छे कामलायां गलाहरे ॥
पित्तरोगे च सर्वेषु वातपित्तरोषु च। सूतिकापनव्याधौ शस्तमेकत्र संशयः ॥
अश्विन्यां पूर्वमुदितः सेव्यो योगोऽयमुत्तमः। एष सौभाग्यदा शुण्ठी स्त्रीणां पुत्रप्रदा शुभा ॥

(योग २० स्त्रीरोग चि०)

४) अन्य नागरपाक (Another nāgarapāka)

नागर आठ पल, घृत बीस पल, क्षीर एक आठक मिलकर आधा तुला शकर डालकर पकायें तथा इसमें शलाह्वा, जीरक, व्याघ्र, त्रिसुगन्धि, यवानिका, कारवी, मिमि, चव्य, अग्नि तथा मुस्ता का एक-एक पल चूर्ण मिला दें। सिद्ध हो कर लेह बन जाने पर इसे घृतपाण्ड में भक्त रख दें। विशेष रूप से सूतिका इसे अग्नि-बल के अनुसार खाए। यह बल्य, वर्ण्य, आयुष्य, बली-पतित-नाशक, वयःस्थापक, हृद्य, मन्दाग्निदीपक, आमवात-नाशक, उत्तम सौभाग्य देने वाला एवं सूतिकारोग तथा मक्कल्ल नाशक है^१।

Nāgara eight *pala*, *ghṛta* twenty *pala*, milk one *āḍhaka* and sugar half *ulā* (50 *pala*) should be mixed and cooked. Now in this powdered *śatābhvā*, *jīraka*, *vyoṣa*, *trisuṅgandhi*, *yavānikā*, *kāravī*, *miṣi*, *cavyā*, *agni* and *muṣṭā* each one *pala* should be mixed and cooked. When it is properly prepared in the form of electuary it should be stored in an earthen pot previously used for keeping *ghṛta*. The puerperal woman should use it according to her digestive power. It is beneficial for strength and complexion, increases longevity, cures graying and falling of hair, is *vyaḡasthāpaka* (prevention of aging or maintenance of youth), *hṛdyā* (cardiotonic), strong appetizer, cures rheumatic disorders, provides fortune and also cures *sūtikārōga* and *makkalla*.

रस (Rasa)

प्रतापलक्ष्मेश रस (Pratāpalakṣmīśvara rasa)

शुद्ध पाद, अभ्रक (भस्म) एवं गन्धक (शुद्ध) एक-एक भाग, मरिच चूर्ण ३ भाग, लौह भस्म ४ भाग, शंखभस्म ८ भाग, जंगली उपतों की भस्म १६ भाग तथा शुद्ध विष एक भाग लेकर क्रमशः मिलकर (पाद गन्धक की कजली बनाकर फिर सब अन्य औषधियाँ मिला) चूर्ण कर दें। प्रसूति-वात में वायु के कारण दाँत बैठ जाने पर आर्द्रक स्वस् के साथ बल्ल-प्रमाण (१५ से ३ रती) में चाटे। वातविकार, श्लेष्मविकार, अशरीर में इस रस को पु, अमृत, त्रिफला एवं आर्द्रक के साथ (चूर्ण, कल्क या क्वाथ) सेवन करे। केवल शुण्ठी-जल या आर्द्रक के स्वस् के साथ सेवन करने से यह सन्निपात सहित उग्ररूप के ज्वर को नाश करता है। निज-निज अनुपात एवं पथ्य के साथ यह रस सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी विकारों को नष्ट करता है। इस प्रतापलक्ष्मेश नाम के रस का प्रयोग पर्वती जी ने किया^१।

Pure *pārada*, (mercury), *abhṛaka* (mica), and *gandhaka* (sulphur) each one part, powdered *marica* three parts, *loha* (iron)-*bhasma* four parts, *śāṅkhā* (conch shell)-*bhasma* eight parts, ash of cow-dung-cakes collected from forests sixteen parts and pure *vija* one part

१. नागास्य पलान्यष्टौ घृतस्य पलविंशतिम्। क्षीराढकेन संयुक्तां खण्डस्यार्धतुलं पक्वेत् ॥

शलाह्वाजीरकव्याघ्रत्रिसुगन्धिव्यानिकाः। कारवीमिषव्याग्निमुस्तानां च पलं पलम् ॥

लेहीभूतिनर्दं सिद्धं घृतपाण्डे निषापयेत्। तद्वधानिवत् खलेत्सूतिका तु विशेषतः ॥

बल्यं वर्ण्यं तथाऽऽयुष्यं बलीपतितनाशकम्। वयसः स्थानं हृद्यं मन्दाग्निदीपनं पयम् ॥

आमवातप्रशमनं सौभाग्यकरमुत्तमम्। मक्कल्लश्लशमनं सूतिकारोगनाशकम् ॥ (योग २० स्त्रीरोग चि०)

२. एकेन्दुचन्द्रानवाधैरन्तीकलैकभागां क्रमशो विमिश्रम्। सुताप्रान्धोषणलोहशंखव्यामृतलभस्मविषं च पिष्टम् ॥
प्रसूतिवतेऽपिलदत्तवन्धे सद्राग्न्यभास बल्लमपुष्य लिह्यात्। वातामये श्लेष्मारेऽपि स स्मृत्यनुपातत्रिफलशुण्ठीऽयम् ॥
सशुङ्गवेदव एष हन्ति ससन्निपातं ज्वमुपश्रव्यं। निजानुपातनिजपथ्ययुक्तः सवीतिसात् ग्रहणीविकात् ॥
प्रतापलक्ष्मेश्वरनामधेयः सूतः प्रयुक्तो गीताजपुष्या ॥ (योग २० स्त्रीरोग चि०)

should be taken. After preparing *kajjali* of *pēraḍa* and *gandhaka* all other drugs should be mixed and powdered. In case of lock jaw due to vitiated *vayu* in *prasthāvivāta* it should be used in the dose of *valla* or three *guṇjā* with juice of *ārdraṭṭa* (*ginger*). In cases of *vāta* disorders, *śleṣmā* disorders and piles it should be used with *pura* (*guggula*), *amṛta*, *triphalā* and *ārdraṭṭa*. If used only with decoction or cold percolation of *śunṭhi* or juice of *ārdraṭṭa* it cures high fever associated with *samipāṇa*. With specific after medicines or adjuvants it cures all types of *atisāra* (diarrhoeas) and *grahmā* (sprue syndrome). This *rasa* is known as *pratāpalañkēśwara* and was used by goddess Parvati.

तैल (Oil)

बला एवं अन्य तैल (Bala and other talia)

मूत्रार्थ-शल्योद्धरण के पश्चात् की चिकित्सा के अन्तर्गत वर्णित बला आदि तैलों का प्रयोग भी कर सकते हैं ।

Balaṭaila etc. oils prescribed in the treatment of *mūḍhagaṛbha* can also be used.

सूतिकारोग में पथ्य (Beneficial diet in sūtikāroga)

सूतिकारोगों तथा वातकफ से उत्पन्न रोगों में उन-उन रोगों के अनुसार पथ्यापथ्य व्यवस्था करें ।

In *sūtikāroga*s and other diseases due to vitiation of *vāta* with *śleṣmā* appropriate congenial diet considering the *dōṣa* and diseases should be given.

(२) प्रसूता की योनिभ्रंश-चिकित्सा (Treatment of yonibhṛṅsa-i.e. uterovaginal prolapse or inversion of uterus of puerperal woman)

यदि प्रसूता स्त्री की योनि का स्वस्थान से भ्रंश हो जाय तो जिस किसी का रक्त मिले (चाहे स्वयं प्रसूता का अपरा के साथ निर्गत रक्त या किसी भी उपलब्ध पशु का) उससे योनि का अभ्यङ्ग करके कुशल स्त्री उसे स्वस्थान में प्रतिष्ठ कर दे । प्रवेश के पश्चात् अशोक्, रोहिणी, बर्हिष, उशीर, प्रियङ्गु तथा देवदार के कल्क के द्वारा विषय तैल से बार बार स्वेदन तथा आपूर्ण करें एवं कहे कि हे सुभगे । तू स्वस्थान को चली जा ।

सूतिका एवं दुग्धजाला को योनिभ्रंश हो जाने पर मद्य-पान कराना अमृत-तुल्य है ।

In case of uterovaginal prolapse or inversion of uterus the *yonī* (uterus and vaginal canal) should be anointed with the blood of either the woman herself or any other available animal and then the *yonī* (uterus) should be replaced in its proper place by an expert woman. After this replacement repeated fomentation and filling or tampon of oil prepared with the paste of *aśoka*, *rohiṇī*, *barhiṣa*, *uśīra*, *prīyaṅgu* and *devadāru* should be given and a woman

१. सूतिकाख्ये रोगेण वातश्लेष्मोद्धये च । तत्ररोगानुकल्पेन पथ्यापथ्याचिन्दिशेत् ॥ (यो० २० क्षी० २० वि०)
२. तस्याश्चेत्स्वस्थानतो योनिभ्रंशये । ततो यस्य कस्मिच्चञ्छोणितेनाप्यव्य योनिं यथास्थानं कुशला स्त्री निवेशयेत् । निविष्टा चाशोकरोहिणीबर्हिषोशीरप्रियङ्गुदेवदारकल्कविश्वेन तैलेन बहुशः स्वेदयेत्पूरुते ॥ ब्रूयाच्च गच्छ सुभगे स्वस्थानमिति ॥ (अ० सं० शा० ३/३६)
३. सूतानां दुग्धजालानां योनिभ्रंशे ॥ ९ ॥
.....मद्यमहुःश्याऽनृतम् ॥ ११ ॥ (का० सं० वि० १६)

should say "O *Subhage* (beautiful vagina) ! go to your proper place".

Drinking of wine by the puerperal woman having undergone normal or difficult labour is like nectar.

३) प्रसूता की योनिक्षत की चिकित्सा (Treatment of yonikṣata or vaginal ulcer of puerperal woman)

गुल्मीय तथा लोष को समान भाग लेकर भलीभाँति पीसकर लेप करने से योनि शीघ्र ही क्षत-रहित हो जाती है ।

Aointment with nicely pestled leaves of *rumḥī* and *lodhira* cures vaginal ulcers quickly.

४) मक्कल्ल शूल (Makkalla śūla or puerperal after-pains)

अ) निदान एवं लक्षण (Etiology and clinical features)

प्रजातायाश्च नार्वा रुक्षशरीरायास्तीक्ष्णैरिवशोभितं रक्तं वायुना तद्देशेनोनातिसंरुद्धं नाभेरथः पार्श्वयोर्बस्ती बस्तिशिरसि वा ग्रन्थिं करोति; ततश्च नाभिबस्त्युदराशूलानि भवन्ति, सूत्रीभिरिव निस्तुब्धते भिद्यते दीर्घत इव च पक्वाशयः समान्तादध्यानामुदरे मूत्रमङ्गश्च भवतीति मक्कल्ललक्षणम् ॥ (सु० सं० शा० १०/२२)

प्रजातायां चेद्वस्तिमुर्धोदरेण शूलं मक्कल्लाख्यं स्यात् ॥ (अ० सं० शा० ३/३५)
मक्कल्लाख्ये शिरोबस्तिरकोष्ठशूलं । (अ० ह० शा० १/९२)

रक्ष शरीर चात्नी प्रसूता स्त्री का तीक्ष्ण औषधियों (पञ्चकोलादि) से अविशोभित रक्त (प्रसवोपपन्न या तो औषधियों प्रयुक्त हो नहीं हुई या यदि प्रयुक्त हुई तो भी वे प्रसवोत्तर स्त्रोहित रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकाल पाई) वायु के द्वारा उसी प्रदेश (गर्भाशय) में रुक कर नाभि के नीचे, पार्श्वों, बस्ति या बस्तिशिर में ग्रन्थि पैदा कर देता है, जिससे नाभि, बस्ति तथा उदर में शूल होता है, पक्वाशय में सूत्री-वेध, भेदन या दारण सदृश वेदना होती है, उदर में चारो ओर आध्मान तथा मूत्रमङ्ग हो जाता है, ये मक्कल्ल शूल के लक्षण हैं ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने अतिसंक्षेप में लिखा है कि प्रसूता स्त्री के बस्तिपार्श्व अथवा बस्ति एवं शिर तथा उदर में उपस्थित शूल को मक्कल्लशूल कहते हैं ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि शिर, बस्ति एवं कोष्ठ के शूल का नाम मक्कल्ल शूल है ।

माधवनिदानकार ने लिखा है कि प्रकृति वायु सुत रक्त को रोक कर प्रसूता के हृदय प्रदेश, शिर एवं बस्ति में शूल उत्पन्न कर देती है उसे मक्कल्ल कहते हैं ।

भावप्रकाश में वर्णन मिलता है कि प्रसूता स्त्री की रुक्षता के कारण वृद्ध वायु तीक्ष्णोष्ण द्रव्यों के प्रयोग से शोषित रक्त को रोककर नाभि के नीचे पार्श्वों, बस्ति तथा बस्तिशिर में ग्रन्थि उत्पन्न कर देती है जिससे नाभि, बस्ति तथा उदर में शूल होता है पक्वाशय में आध्मान तथा मूत्रमङ्ग हो जाता है । वैद्यों के द्वारा मक्कल्ल शूल के यही लक्षण कहे

१. गुल्मीयं तथा लोषं समभागं सुषेधयेत् । तेन लेपे यो कार्यः शीघ्रं स्वाशोनिश्चला ॥ (मा० प्र० वि० ७०/१२८ एवं यो० २० स्त्री० वि०)
२. (वायुः प्रकृतिः कुर्यात् संरुध्य शीघ्रं सुतम् । सूताया हृच्छोर्बस्तिशूलं मक्कल्लसंज्ञकम् । ११) (मा० वि० ६२)
(सम्भवतः श्लोक प्रक्षेप है)

गए है^१।

योगात्माकर में माधवनिदान सदृश ही वर्णन है^२।

Unexcreted or unpurified blood, inspite of use of pungent drugs by a puerperal woman having dry (absence of unctuousness) body, gets localised by *vāyu* in the uterus or else the excreted blood is retained by *vāyu* in the uterus. This retained blood produces a glandular structure in any site amongst infraumbilical region, flanks, bladder or bladder-neck (hypogastric) region. Due to this structure there is severe pain in umbilical and bladder regions, abdomen and cardiac region and headache. In the *pakwāśāya* (large bowel) region there is severe pain as if needles are being pricked, the bowel is being torn or perforated. Flatulence and retention of urine also occur.

ब) मक्कल-चिकित्सा (Treatment of makkala)

- १) वीरतादि गण की औषधियों के क्वाथ में ऊषकादि गण की औषधियों का प्रक्षेप देकर^३ घृत, मद्योष्ण जल या नमक के चूर्ण के साथ पीने को दे^४।
- २) यवक्षार का चूर्ण पिप्पल्यादि गण के क्वाथ^५ अथवा घृत या सुखोष्ण जल^{२,३,४,५} के साथ पीने को दे^६।
- ३) पिप्पल्यादि गण के चूर्ण को सुरामण्ड के साथ दे^७।
- ४) वरणादि गण के क्वाथ में पञ्चकोल एवं एला (के चूर्ण) का प्रक्षेप देकर पीने को दे^{८,९}।
- ५) पृथक्पृथग्गणों के क्वाथ में भद्रदार एवं मरिच मिलकर दे^{१०}।
- ६) त्रिकटु, चतुर्जित^{१,४,५} अथवा त्रिजात^{२,३} एवं कुसुम्बुर के साथ पुराना गुड़ खाये^{१,२,३,४,५}।
- ७) केवल अच्छे अरिष्ट (शुद्ध एवं अच्छे अरिष्ट) का प्रयोग करे^१।
- ८) वत्सकादि गण की औषधियों के क्वाथ में त्वण का चूर्ण मिलाकर अथवा वत्सकादि गण (की औषधियों के चूर्ण) को मदिरा के साथ दे^२।
- ९) अंशुमतीद्वय के क्वाथ में मरिच तथा भद्रदार के कल्क को मिलाकर प्रयोग करावे^{३,४}।
- १०) भाङ्गी, नागर तथा देवदार के कल्क को गर्म जल से दे^३।
- ११) पिप्पली, पिप्पलीमूल, मरिच, गजपिप्पली, नागर, त्रिकक, चव्य, रेणुका, एला, अजमोद, सर्षप, हिंगु, भागी, पाठा, इन्द्रधनु, जौरा, महाविष्य, मूला, विषा, तिका तथा विडङ्ग यह पिप्पल्यादि गण कफ-वात नाशक है। इसके क्वाथ का त्वण के साथ प्रयोग गुल्म-शूल, ज्वर, मक्कल-शूल, गुल्म एवं कफ तथा वात-विकारों का नाशक, उत्तम दीपन एवं पाचन है^{४,५}।
- १२) रक्त वर्ण बोल को घृत तथा पुराने गुड़ के साथ बढी बनाकर खाने से मक्कल शूल तथा अन्य रक्तजन्य उपद्रव शान्त होते हैं^१।

१. वसिष्ठः प्रस्ताव्य वातो रूक्षेण वर्द्धितः। तीक्ष्णोष्णशीघ्रं रक्तं रूद्धा ग्रन्थिं करोति हि ॥ १३६॥

नाप्यधःपार्श्वयोर्भरतौ वसिष्ठमूर्ध्नि चापि वा। ततश्च नामौ वरतौ च भवेच्छूलं तथोदरे ॥ १३७॥

भवेत्तक्षायापमानं मूत्रसङ्घं जायते। एतद्विषमिभरितं मक्कलामयलक्षणम् ॥ १३८॥ (भा० प्र० चि० ७०)

२. वायुः.....व्युत्पन्नः.....मक्कल संज्ञितम् ॥ (भा० चि० सदृश) (यो० २० स्त्रीतो० चि०)

नोट -मक्कल-चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ५७५ में देखें।

१३) शुद्ध हिंगु को घृत के साथ खाने से मक्कल शूल का नाश होता है^१।

Following preparations should be given orally:—

- i) In the decoction of *virataravādi* group of drugs, powdered *īśakādi* group of drugs should be mixed and be prescribed either with *ghṛta*, lukewarm water or powdered salt.
- ii) Powdered *yavakṣāra* with the decoction of *pippalyādi* group of drugs or *ghṛta* or lukewarm water.
- iii) Powdered *pippalyādi* group of drugs mixed with *sūramāṇḍa* (scum of wine).
- iv) Decoction of *varuṇādi* group of drugs mixed with powdered *pañcakola* and *ela*.
- v) Decoction of *prithakpariyādi* group of drugs mixed with *bhadradāru* and *marica*.
- vi) *Trikatu*, *caturjāta* or *trijāta* and *kusumburu* mixed with old jaggery.
- vii) Only pure and best *ariṣṭa*.
- viii) Decoction of *vasakādi* group of drugs mixed with salt or powdered *vasakādi* group of drugs with wine.
- ix) Decoction of *anśumati-dwaya* (*śālaparyā* and *prāñjaparyā*) mixed with paste of *marica* and *bhadradāru*.

१. तत्र (सर्षिषा सुखोदकेन वा त्वणचूर्णेन-कलकता प्र०) वीरतादिसिद्धं जलमूषकादिप्रतीवापं पाययेत् यवक्षारचूर्णं वा सुखोदकेन पिप्पल्यादिक्वाथेन वा पिप्पल्यादिचूर्णं वा सुरामण्डेन, वरणादिक्वाथं वा पञ्चकोलैलाप्रतीवापं, पृथक्पृथग्द्विक्वाथं वा भद्रदारमरिचसंघं, पुणगुडं वा त्रिकटुकचतुर्जितकुसुम्बुरभिर्भ्रं खादेत् अच्छं वा पिकेदीष्टिमिति ॥

(सु० सं० शा० १०/२२)

२. तत्र यवक्षारचूर्णं सर्षिषा सुखोष्णोदकेन वा पिकेत्। वरणादि वा सपञ्चकोलनेलाप्रतीवापं। अथवा वीरतादि-मूषकादिप्रतीवापं। त्वणचूर्णं वा वत्सकादिनिर्दूषेण। वत्सकादि वा मदिरा। अंशुमतीद्वयक्वाथेन वा मरिचभद्रदार-रक्तकम्। भाङ्गीनागरदेवदाररक्तं बोष्णामसा। पुणगुडं वा त्रिकटुत्रिजातकचनिकाचूर्णसंघं भक्षयेत् ॥

(अ० सं० शा० ३/३५)

३. तु पाययेत्। सुचूर्णितं यवक्षारं घृतेनोष्णं जलेन वा ॥ १२॥

षायायान् वा गुडव्योषत्रिजातकरजोन्मिलम् ॥ (अ० ह० शा० १/९२, ९३)

४. सुचूर्णितं यवक्षारं पिकेकोष्णेन वारिणा। सर्षिषा वा पिकेनारी मक्कलस्य निवृत्तये ॥ १३॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली। नागरे चित्रकं चव्यं रेणुकैलाजमोदिकाः ॥ १४०॥

सर्षपो हिङ्गु भागी च पाठेन्द्रयवजोत्तमाः। महाविष्यं मूला च विषा तिका विडङ्गकम् ॥ १४१॥

पिप्पल्यादिगणो ह्येष कफमरुतनाशनः। क्वाथमेषां पिकेनारी त्वणेन समन्वितम् ॥ १४२॥

गुल्मशूलज्वरहरे दीपनञ्चामपाचनम्। मक्कलशूलगुल्मज्वरं कफानिलहरे यम् ॥ १४३॥

त्रिकटुकचतुर्जितकुसुम्बुरचूर्णसंघम्। खादेत् गुडं पुणं नित्यं मक्कलदलनाय ॥ १४४॥ (भा० प्र० चि० ७०)

५. संचूर्णितं.....निवृत्तये ॥ पिप्पली मोदिकाः ॥ सर्षपो.....विडङ्गकम् ॥

पिप्पल्यादि.....समन्वितम् ॥ गुल्मशूल.....पाचनः। मक्कल.....परम् ॥

त्रिकटुक.....संघृतं नित्यं। खादेत्.....दलनाय ॥ (भा० प्र० चि० ७० सदृश)

शोणं बोलं सघृतं सगुडं गुटकीकृतं मिलितम्। मक्कलामिधिशूलं हन्ति सगुलं सगोणितलङ्कम् ॥

हिङ्गु शुद्धं ससर्षिकं पुक्तं मक्कलशूलनात् ॥ (यो० २० स्त्रीतो० चि०)

- x) Pestled *bhāṅgū*, *nāgura* and *devadāra* with warm water.
- xi) *Pippalī*, *pippalīmūla*, *maricā*, *guṇḍapippalī*, *nāgura*, *citrakā*, *cayva*, *reṇukā*, *ela*, *ajamodā*, *sarsapa*, *hingū*, *bhāṅgū*, *pāthā*, *indrayava*, *jīra*, *māhānimbā*, *māra*, *viṣṭā*, *nīkā* and *vidāṅga* are the drugs of *pippalyādi* group, which suppresses *kapha* and *vāta*, use of decoction of this group with salt cures pain due to *gūlma*, fever, *makkalla śūla*, *gūlma* and disorders of *kapha* and *vāta*. It is good appetizer and digestive.
- xiii) Use of tablets prepared with red coloured *bola*, *ghṛta* and jaggery cure *makkalla śūla* and other complications arising due to *rakta*.
- xiv) Use of pure *hingū* with *ghṛta* cures *makkalla śūla*.

५) रक्तविद्रधि (Raktavīdradhī)

निदान एवं लक्षण (Etiology and clinical features)

स्त्रीणामप्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितैः । दाहचरकरो घोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ २६ ॥
अपि सम्यक्प्रजातानाममूर्क कायादनिःसृतम् । रक्तं विद्रधिं कुर्यात् कुक्षौ मक्कल्लसीर्गतम् ॥ २७ ॥
समाहान्योभयान्तरधेत् ततोऽसौ संप्रच्यते ॥ (सु० सं० नि० १/२६ से २८)

अप्रजाता (पतित गर्भा) अथवा असामान्य रूप से प्रसूता) अथवा प्रजाता (सम्यक् काल में सामान्य रूप से प्रसूता) स्त्री को अहित सेवन (शीत एवं रुख आहार-विहार) से दाह एवं चरक उत्पन्न करने वाली तीव्र रक्तविद्रधि उत्पन्न हो जाती है अथवा प्रसूता स्त्री के शरीर से (गर्भाशय से) सम्यक् रूप से रक्त के न निकलने से मक्कल्ल शूल के द्वारा उत्पन्न या मक्कल्ल नाम की रक्तविद्रधि हो जाती है, जो यदि एक सप्ताह में शांत न हुई तो पाक को प्राप्त हो जाती है जिस पाक का कारण पित्त-जनित आन्तरिक उष्णता है । पक्व हो जाने पर यह असाम्य हो जाती है ।

Due to use of non-congenial diet or harmful mode of life, the woman who had abortion, normal or abnormal labour suffers from serious *raktavīdradhī* which produces burning sensation and fever, however, sometimes in normally delivered woman unexcreted blood from the body (uterus) causes *makkallaśūla* which subsequently produces *raktavīdradhī*, this *vīdradhī* if not relieved within a week gets suppurated. *Dālhaṇa* has explained that supuration occurs due to internal heat generated by *pitta* and after supuration it becomes incurable.

विमर्श (Comments)

सभी संहिताकारों ने विद्रधि के चाल, पित्त, कफ, सनिपात, रक्त तथा अभिघात आदि से होने वाले ६ भेदों का वर्णन किया है । महर्षि सुश्रुत ने इन ६ विद्रधियों के वर्णन के बाद ही स्त्रियों में होने वाली रक्तविद्रधि का उल्लेख किया है, अर्थात् महर्षि सुश्रुत के मत से धातु-रूप रक्त की अन्तर्विद्रधि स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकती है, परन्तु शरीर (गर्भाशय) से प्रसवोपरांत समुचित रूप से न निकलने वाले रक्त या मक्कल्ल के कारण होने वाली विद्रधि केवल स्त्रियों में ही होती है । चूँकि यह भी धातु-रूपी रक्त के ही एक परिवर्तित स्वरूप अर्थात् प्रसवोपरांत गर्भाशय में एकीकृत रक्त में उत्पन्न होती

१.अप्रजातानां पतितगर्भाणां । प्रजातानां सम्यक्कालप्रसूतानाम् । अहितैः शीतरक्षारविहारैः

मक्कल्लसिर्गतं मक्कल्लजनितं, कारणे कायोपचारात्: सप्ताहप्रशान्तः पित्तोष्णपातः प्रपच्यते । पक्वक्षसाध्यः ॥

(सु० सं० नि० १/२६ से २८ की उत्तरण टीका)

है अतः इसका समवेश संख्या-गणना में सामान्य रक्तविद्रधि के ही अन्तर्गत हो जाता है । महर्षि वाग्भट का कथन है कि रक्तज अन्तर्विद्रधि केवल स्त्रियों को ही होती है पुरुषों को नहीं । टीकाकार इन्द्र का मत है कि बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार की रक्तविद्रधि केवल स्त्रियों में ही होती है^१ । मधुकोष व्याख्याकार ने विभिन्न मतों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि भोजादि आचार्य तो धातु-रूपी रक्त की विद्रधि को न मानकर मक्कल्ल संज्ञक आर्तव-लक्षण रक्त से होने वाली विद्रधि को ही रक्तज विद्रधि के नाम से मानते हैं । उनके मत से अर्तवज विद्रधि ही छठी या रक्तज विद्रधि है । सुश्रुत में धातुरूप रक्तज तथा मक्कल्ल संज्ञक दोनों ही विद्रधियों को पृथक् पृथक् मानते हुए इसे रक्तज के ही अन्तर समाविष्ट कर दिया है जिससे संख्या छः हो रहती है^२ ।

महर्षि सुश्रुत का वर्णन अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि धातुरूपी रक्त की अंतः एवं बाह्य विद्रधि स्त्री या पुरुष किसी को भी हो सकती है जिसे हम इमेकेस्ट्र इन्टर्नल एवं एक्सटर्नल हीमेटोम मान सकते हैं, परन्तु मक्कल्ल के बाद या गर्भाशयिक रक्तज अन्तर्विद्रधि केवल स्त्रियों में ही होगी ।

आचार्यों ने किन्हीं भी अन्तर्विद्रधियों के पृथक् लक्षणों का वर्णन नहीं किया अर्थात् बाह्य विद्रधि में होने वाले लक्षण ही अन्तर्विद्रधि में होंगे । सभी आचार्यों के मत से रक्तविद्रधि कृष्ण स्फोटों से आवृत, श्याव वर्ण की, तीव्र वेदना, दाह, तथा चरक युक्त एवं पित्तविद्रधि के लक्षणों वाली होती है^३ ।

कृष्ण स्फोटों आदि से आवृत स्त्रियों की विशिष्ट अन्तर्विद्रधि का आधुनिक दृष्टिकोण से सामञ्जस्य कठिन है । सम्भवतः यह गर्भाशय की अतितीव्र पाकावस्था का द्योतक है । महर्षि सुश्रुत वर्णित रक्तविद्रधि का स्पष्टीकरण इस प्रकार दे सकते हैं—

गर्भशय या प्रसव के बाद गर्भाशय में गर्भ या अपरादि के किसी अंश के रह जाने से उसमें उपसर्ग-जन्म शोथ अथवा पाकोत्पत्ति हो गर्भाशय-विद्रधि अथवा सामान्य सूतिका को भी कभी कभी उपसर्ग-जन्म गर्भाशय अथवा श्रोणि-गुहा की विद्रधि बन जाती है । गर्भाशय में किसी भी कारण से एकत्रित रक्त जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है । प्रसूता की गर्भाशय एवं श्रोणिगुहा की विद्रधि आज भी यदि असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य ही है, अतः रक्तविद्रधि प्रसवोपरांत गर्भाशयान्तर पूमयता (पयोमेट्रा) अथवा श्रोणिगुहा की विद्रधि का वर्णन प्रतीत होती है ।

All the authors have classified *vīdradhī* (abscess) into six types i.e., *vātaja*, *pitta*, *kaphaja*, *sannipāta*, *raktaja* and *abhiṅghāta*. After describing all these six, *Sūstrā* has described *raktavīdradhī*. It seems that according to *Sūstrā antavīdradhī* (internal abscess) developing from *dhātū* form of *rakta* develops in both sexes i.e., male and female, however, the abscess of unexcreted blood from the uterus after delivery or *makkalla* develops only in woman. Since the blood accumulated in uterus is not different from general blood of

१. (अ) स्त्रीणामेव तथाऽऽन्तरः ॥ (अ० सं० नि० ११/१२)

(आ) स्त्रीणामेव तथाऽन्तरः ॥ (अ० इ० नि० ११/१०)

२. स च बाह्योऽप्यन्तरो वा स्त्रीणामेव भवति ॥ न तु पुरुषाणां इति रक्तविद्रधिः ॥ (अ० सं० नि० ११/१२ की इन्द्र टी०)

३. भोजेन पूतयस्तु धातुरक्तं विद्रधिं पतितञ्च मक्कल्लसंज्ञकाऽन्तर्वलक्षणकत्वं पठितम् । तेषां मते अर्तवजेन सह षड्विद्रधयः, सुश्रुते तु धातुरक्तजोऽपि तथा मक्कल्लसंज्ञकजोऽपि विद्रधिः सामान्येन रक्तं प्लेति षड्विद्रधय इति बोद्धव्यम् ।

(म. नि० ४०/१० की मधुकोषव्या०)

४. (अ) कृष्णस्फोटानुवृत्तः श्यावस्तीव्रदाहश्चाच्चरः ॥ पित्तविद्रधिरित्युक्तं रक्तविद्रधिरच्यते ॥ (सु० सं० नि० १/२३, २४)

(आ) कृष्णस्फोटानुवृत्तः श्यावस्तीव्रदाहश्चाच्चरः । पित्तलिङ्गोऽसुजा बाह्यः स्त्रीणामेव तथाऽन्तरः ॥

(इ) कृष्णः..... पित्तः..... तथाऽन्तरः ॥ (अ० सं० सदृश) (अ० इ० नि० ११/१०)

(अ० सं० नि० ११/१२)

body, hence under classification this is included in *rakavidradhi*.

According to Vāgbhata internal *rakaja vidradhi*, while according to Indu external and internal both *rakaja vidradhi* develop only in woman.

Bhoja (quoted in Madhukosa commentary) says that from *dhiāu* form of *rakia* the *vidradhi* does not develop, however, it develops only from the *rakia* accumulated in uterus after delivery or *makkala* which is a form of *āraṭa*.

Opinion of Suśruta seem to be more logical because internal and external *rakaja-vidradhi* (infected internal and external haematomas) can develop in either of the sex, however, uterine abscess of unexcreted blood after delivery develops only in females.

Clinical features of only external abscesses have been described in the books with the indication that internal abscesses are identical to external ones. Clinical features of external *rakaja vidradhi* are—that it is covered with black blisters, is of black colour and associated with severe pain, burning sensation, fever along with other features of *pitaja vidradhi*.

On the basis of these clinical features it is difficult to establish congruence with any uterine disorder. It could be some acute infective/pyogenic condition of uterus. Explanation of *rakavidradhi* described by Suśruta is being given here.

After abortion or abnormal delivery, if some products of conception are retained, these may get infected and cause inflammation and suppuration thus produce abscess in the uterus. However, sometimes even in normally delivered woman due to infection some inflammation and suppuration inside the uterus or pelvic cavity may occur. If blood clots are retained in the uterus these may facilitate growth of pyogenic bacteria. The abscess of uterus and pelvic cavity if not incurable are difficult to be cured even to-day. Considering these points this *rakavidradhi* seems to be description of acute puerperal pyometra or pelvic abscess.

चिकित्सा (Treatment)

अ) सिद्धान्त (Principles of treatment)

अपक्व विद्रधि में शोफ तथा आप्चन्तर विद्रधि में गुल्म-सदृश चिकित्सा करनी चाहिए^१।

रक्तज एवं आगन्तुज (क्षतज) विद्रधि में पित्तविद्रधि के सदृश ही कुशल वैद्य को सम्पूर्ण चिकित्सा इसके पूर्णरूपेण समाप्त हो जाने तक करनी चाहिए^२। चूँकि यह रक्तज विद्रधि अन्तर्विद्रधि है अतः सामान्य अन्तर्विद्रधि के लिए वर्णित चिकित्सा का भी प्रयोग करना चाहिए।

१. (अ) सर्वमेवविद्रधिमानं शोफविधिना यथादोषमुपाचरेत् ।। यथादोषं च सर्वशो गुल्मवदुपक्रमेत् ॥ (अ० सं० चि० १५/२ व ३)

(आ) विद्रधिं सर्वमेवापं शोफवत् समुपाचरेत् ॥ १॥

सर्वशो गुल्मवत्त्वं यथादोषमुपाचरेत् ॥ २५॥ (अ० ह० चि० १३/१ एवं २५)

२. (अ) पित्तविद्रधिर्वत् सर्वाः क्रिया भिन्नशेषाः । विद्रध्योः कुशलः कुर्याद्रक्तजानुनिमित्तयोः ॥ (सु० सं० चि० १६/२०)

(आ) रक्तजानुद्भवे कार्या पित्तविद्रधिवचिक्रिया ॥ (अ० ह० चि० १३/०)

Vidradhi during its stage of inflammation (*apakwa*) should be treated like *śophā*, *antavidradhi* should be treated like *gūlma*.

The wise physician should treat this *rakavidradhi* on the line of *pitaja vidradhi*, which treatment should continue till it is completely cured.

औषधियाँ (Drugs)

पित्तविद्रधिवत् होने से पित्त-विद्रधि तथा अन्तर्विद्रधि के अन्तर्गत वर्णित औषधियाँ प्रयोग की जानी चाहिए।

बाह्य प्रयोग

१) पित्तविद्रधि में शर्करा, लाजा, मधुक तथा सारिवा अथवा पयस्या, उशीर एवं चन्दन को दुग्ध के साथ पीसकर लेप करना चाहिए^१ अथवा मधुयुष्टी, अमृता एवं तिल का अथवा मधुशुण्ड-त्वचा का लेप करें^{२,४,५}।

२) उपर्युक्त औषधियों के क्वाथ या शीतक्वाथ अथवा दुग्ध या गन्ने के रस या शर्करा युक्त जीवनीय घृत (जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध घृत)^१ अथवा क्षीरी वृक्षों के क्वाथ से परिचिन्त करें^१।

३) स्नेहन, उपनाह तथा अनुलोमन का सदा प्रयोग करना चाहिए^३।

४) पक्व विद्रधि का उत्पादन (विदारण) करके क्षीरी वृक्ष अथवा औदकज (जल में उत्पन्न होने वाले कमल, कुमुदिनी आदि) द्रव्यों के क्वाथ से (व्रण का) प्रक्षालन करके तिल एवं मधुयुष्टी (के कल्क) को मधु एवं घृत के साथ मिलकर लेप करके फलते कपड़े से बाँध देना चाहिए^१।

(गर्भांशयिक विद्रधि का उदरभित्ति के मार्ग से उत्पादन सामान्यतया वर्जित नहीं होता, अतः उत्पादन के स्थान में गर्भांशयिका के मार्ग से पूर-निर्हरण कर उपर्युक्त औषधियों का बस्तिनेत्र के द्वारा गर्भांशय में प्रवेश एवं श्रोणिगुहा-विद्रधि में योनिनलिका के पश्चिम भित्ति के उन्नत स्थान से उत्पादन तत्पश्चात् औषधि प्रयोग अथवा डगलस पाउच के मार्ग से पूर-निर्हरण करना चाहिए।) रोपण के लिए निम्न घृतों का प्रयोग करना चाहिए^१।

अ) प्रपौण्डरीक, मञ्जिष्ठा, मधुक, उशीर, पचक तथा हरिद्रा (के कल्क) एवं दुग्ध से निर्मित घृत व्रणरोपक होता है^१।

आ) क्षीरशुक्ला, पृथक्पर्णी, समझा, तोष, चन्दन तथा न्यग्रोधादि (वर्ग की औषधियों) के कोमल पत्र अथवा त्वक् से सिद्ध घृत व्रणरोपक होता है^१।

इ) करञ्जाव घृत - नकमाल (करञ्ज) के पत्ते तथा कच्चे फल, सुमना, पटोल एवं अरिष्ट के पत्ते, दोनों हरिद्रा, मधुच्छिष्ट (मोम), मधुक, तिकोहीणी, भियङ्गु, कुशमूल, निचुल की त्वचा, मञ्जिष्ठा, चन्दन, उशीर, उत्तल, सारिवा (पाठभेद सारिबे या सारिवाद्य) तथा त्रिवृत सभी के एक-एक कर्ष (कल्क) के साथ एक प्रस्थ घृत का पाक करें^१। यह दुग्धव्रण-शामक, नाडीव्रण-शोथक, सधोव्रण एवं छिन्नव्रण आदि के लिए लाभदायक कञ्जाव घृत है^१।

ई) मञ्जिष्ठा, उशीर, पचक, पयस्या, निशाद्य, श्रेष्ठा, यष्टी तथा दुग्ध से साधित घृत से रोपण करें^१।

उ) न्यग्रोधादि गण के वृक्षों के कोमलपत्र, त्वचा एवं फलों से साधित घृत से रोपण करें^१।

आप्यन्तर प्रयोग

१) त्रिवृत एवं हरीतकी का चूर्ण मधु मिलाकर चाटना चाहिए^१।

नोट-सन्दर्भ पृष्ठ ५८१ से ५८३ में देखें।

२) अपक्व अन्तर्विद्रीध में ऊषकादिगण के प्रक्षेप से युक्त वरुणादि गण का सुखकारी क्वाथ पूर्वार्ह में^{३४५} पिलना चाहिए^{३४५} ।

३) इन्हीं दोनों वर्गों (ऊषकादि एवं वरुणादि) एवं विरेचन द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन विद्रीध को शीघ्र ही नष्ट कर^{३४५} देता है ।

४) दोषानुसार प्रक्षेप के साथ पान एवं भोजन में मधुशिशु वृक्ष (को त्वचा) का प्रयोग अपक्व विद्रीध का नाश करता है^{३४५} । टीकाकार डह्लण का कथन है कि मधुशिशु स्वभावतः ही आम विद्रीध में लाभदायक होता है । इसके कषाय-पाचन के समय दोष प्राधान्य के आधार पर वात, पित्त एवं कफ नाशक द्रव्यों का प्रक्षेप दे देना चाहिए ।

५) जल (पित्तज विद्रीध में), काँजी (वातज विद्रीध में), मूत्र (कफज विद्रीध में) अथवा सुरा के साथ मधुशिशु (के चूर्ण) अथवा दोषहर (वातादि दोष-नाशक) द्रव्यों के क्वाथ के साथ शिलानजलु का सेवन करना^{३४५} चाहिए ।

६) शुण्ठी (कफज में) एवं सुरदारु (वातिक में) के साथ प्रधान (महिषाक्ष^३) गुग्गुलु का सेवन करना चाहिए^३ अथवा केवल गुग्गुलु का सेवन करें^{३४५} ।

७) त्रिफला, पित्तुमन्द, मधुक, कटुका, पटोल प्रत्येक एक एक शौण, त्रिवृत एवं त्रायमाण एक-एक कर्ष एवं मसूर एक पल मिलाकर आठ गुणे जल के साथ क्वाथ बनाकर उसमें घृत मिलाकर पिए । इससे विद्रीध नष्ट होती^३ है; अथवा त्रायन्ती, त्रिफला, निम्ब, कटुका तथा मधुक १-१ भाग, त्रिवृत एवं पटोल की मूल चार-चार भाग तथा छिलका रहित मसूर ८ भाग का क्वाथ उपर्युक्त विधि से प्रयोग करें^३ ।

८) त्रायमाण का क्वाथ एक प्रस्थ, मुस्ता, कटुका, तामालकी, त्रायमाण, चन्दन, दुरालभा, जीवन्ती, वीरा एवं उत्पल प्रत्येक एक एक पल, घृत एक प्रस्थ, दुग्ध एवं आमलकी-स्वरस एक-एक प्रस्थ लेकर घृत पाक करें । यह घृत भी पूर्व-वर्णित घृत के समान गुणकारी है^३ । अष्टांगहृदयकार ने प्रस्थ के स्थान पर कुड़वं तथा पल के स्थान पर कर्ष मात्रा वर्णित की है^३ ।

९) द्राक्षा, मधुक, खर्जूर, आभीर, विवरी, परुषक एवं त्रिफला के क्वाथ में दुग्ध, इक्षु एवं धात्री-स्वरस तथा अभया-कल्क मिलाकर घृत पाक करें । शीतल होने पर इसमें चौथाई भाग मधु एवं शर्करा मिला दें यह भी पूर्व के समान हितकारी है^{३४५} ।

अनुवासन एवं आस्थापन-बस्ति

वरुणादि, ऊषकादि एवं विरेचक द्रव्यों के क्वाथ में स्नेह (तेल) मिलाकर आस्थापन एवं अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना^{३४५} चाहिए ।

विद्रीध में रक्तमोक्षण या शिरावेध

जलौका^{३४५} अथवा शृंग^{४५} के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिए^{४५} । रक्तज एवं पित्तज विद्रीध में बाहु की शिरा का वेध करना^{३४५} चाहिए ।

कोष्ठगत पच्यमान विद्रीध में उपनाह का निर्देश

कोष्ठ की पच्यमान विद्रीध जो बाहर की ओर उन्नत हो गई हो उस पर उपनाह का प्रयोग करें^{४५} ।

विद्रीध की पाक से रक्षा एवं पाक का परिणाम

विद्रीध में पाक न हो इसका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । शीघ्र विद्रीही होने के ही कारण इसे विद्रीध कहते हैं । पक

नोट-सन्दर्भ पृष्ठ ५८१ से ५८३ में देखें ।

जाने पर चिकित्सा देवार्थन ही होती है एवं सभी व्याधियों की अपेक्षा इसकी अतिशय चिकित्सा करनी होती है^{४५} ।

विद्रीध की पक्वावस्था की परीक्षा एवं पूय निर्हरण की विधि

विद्रीध में शूल के एक स्थान पर पिण्डिताकार (सीमित) हो जाने, (विद्रीध के) फाख में दबाने पर सुसता (शून्यता या वेदना रहितता) होने, दाह आदि कम होने एवं शरत्-कर्म में वर्णित लक्षणों को देखकर इसे पका हुआ जानकर इसका भेदन करके व्रण की भाँति चिकित्सा करें^{४५} । आभ्यन्तर विद्रीध को इसी प्रकार से पका हुआ जानकर अथवा पूय के ऊर्ध्व या अधो मार्ग से प्रवृत्त होने पर, उपद्रवों से रक्षा करते हुए दस दिन^४ या १२ दिन^४ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए^{४५} ।

आभ्यन्तर विद्रीध में पूय का सम्यक् निर्हरण न होने पर चिकित्सा

पूयस्राव सम्यक् प्रकार से न होने या क्लेश होने पर इसके निर्वहण करने के लिए अम्ल (काँजी), सुरा, आसव, मैरय या उष्णोदक के साथ वरुणादि गण की औषधियों अथवा मधुशिशु (के कल्क या क्वाथ) का पान करें^{४५} ।

उन्हीं के (वरुणादि गण की औषधियों अथवा मधुशिशु के) मूल से साधित यथागु को यव, कोल एवं कुलत्थ के घृष के साथ खाएँ^{४५} ।

दश दिन के पश्चात् तिल्वक घृत या त्रायमाण घृत के द्वारा बलानुसार शोधन करें (विरेचन दें)^{४५} ।

शोधन हो जाने के बाद मधु मिलाकर तिकक घृत का अल्प-अल्प मात्रा में (बार बार परन्तु थोड़ी-थोड़ी मात्रा) प्रयोग करें^{४५} ।

१. पैत्तिक शर्करालाज मधुकः साविधुतैः । प्रदिह्यात् क्षीरपिष्टैर्वा पयस्त्रयोविचन्दनैः ॥ १० ॥

पाक्यैः शीतकाषादैर्वा क्षीरैश्चुरसैस्तथा । जीवनीयवृत्तैर्वापि सेवयेच्छकण्डवैः ॥ ११ ॥

निवृद्धरीतकोनां च चूर्णं लिह्यान्मधुद्वयम् । जलौकाभिहरेन्मासुर्कं पक्वं चापान्द्वयं बुद्धिमान् ॥ १२ ॥

क्षीरवृक्षकाषायेण प्रक्षालयेदकजेन वा । तिलैः समष्टिमधुकैः सक्षरैः सर्पिण्युतैः ॥ १३ ॥

उपादिह्यं प्रानुनां वाससा वेधयद् व्रणम् । प्राण्डरीकमञ्जिष्टमधुकोशीपयकैः ॥ १४ ॥

सहरिदैः कृतं सर्पिः सक्षरं व्रणरोपणम् । क्षीरशुक्लापृथक्पार्णसङ्काशोपचन्दनैः ॥ १५ ॥

न्योषादिप्रवालैश्च तेषां त्वक्षयवा कृतम् । नक्तमालस्य पत्राणि तरुणानि फलानि च ॥ १६ ॥

सुमनायाश्च पत्राणि पटोलानिद्योस्तथा । द्वै हरिदै मधुच्छिद् मधुकं तिकरोहिणी ॥ १७ ॥

प्रियङ्गुः कुशमूलं च निचुलस्य त्वगेव च । मञ्जिष्टाचन्दनोशीरुमूलं सर्पिषे त्रिवृत् ॥ १८ ॥

एतेषां कर्षिकैर्भीरीवृत्तप्रस्थं विपाचयेत् । दुष्टव्रणप्रशमनं नाडीव्रणविशेषणम् ॥ १९ ॥

सह्यश्लिजव्रणानां च करञ्जाधिमिदं शुभम् । (सु० सं० वि० १६/१० से २०)

२. वरुणादिगणक्वाथमक्वेऽप्यन्तरीरिथते । ऊषकादिप्रणीवापं भिवेद् सुखकरं नः ॥ २८ ॥

अनयोर्वागोः सिद्धं सर्पिर्वैचनेन च । अचिराद् विद्रीधं हन्ति प्रातः प्रातिभित्तम् ॥ २९ ॥

एभिरेव गणैश्चापि संसिद्धं स्नेहसंयुतम् । कार्यमास्थापनं क्षिप्रं तथैवाप्यनुबानम् ॥ ३० ॥

पानलेपनभोज्येषु मधुशिशुदुग्धोऽपि वा । दत्तावापो यथादोषमपक्वं हन्ति विद्रीधम् ॥ ३१ ॥

तोयधान्यात्ममूर्धैस्तु पेया वापि सुरादिभिः । यथादोषाणक्वाथैः भिवेद् बाधभिः शिलानजलु ॥ ३२ ॥

प्रधानं गुग्गुलुं चापि शुण्ठीं च सुरदारु च । स्नेहोपगहौ कुयाच्च सदा चाप्यनुलोमम् ॥ ३३ ॥

यथादिष्टां सितां विष्येत् । रक्तपित्तानिलोत्थेषु केचिद् बाहौ वदन्ति तु ॥ ३४ ॥ (सु० सं० वि० १६/१८ से ३४)

३. स्वभावत एवामविद्रीधप्रत्यन्तीको मधुशिशुः । कषायपाचनान्दिषु तस्य तु दोषस्य प्रत्यन्तीक दोषानतिक्रमेण व्रणहितवायुपित्त-कफहृदयप्रक्षेपः । । तत्र तोयेन पित्तविद्रीधौ, धान्यान्त्येन वातविद्रीधौ, मूत्रेण कफविद्रीधौ । । प्रधानं गुग्गुलुं

क्रमशः

drugs should be applied for healing of wound.

Oral medicines

i) Powdered *trivrt* and *haritakī* mixed with honey should be licked.

ii) Lukewarm decoction of *varuṇādi* group of drugs mixed with powdered *uśakādi* group of drugs should be given in a case of *apakwa antarvidradhi* (non-suppurated internal abscess).

iii) *Ghṛta* prepared with the drugs of *uśakādi*, *varuṇādi* and *virecanīya* group if used daily in the morning hours cures abscess very quickly.

iv) Use of stem-bark of *madhuśiṅgu* in the form of tisan and diet mixed with drugs on the basis of vitiation of specific *doṣa* is beneficial in non-suppurated abscess, or else the drugs capable of suppressing *vāta* etc. dominant *doṣa* should be mixed while preparing the decoction.

v) Use of powdered *madhuśiṅgu* with water in *pittaja vidradhi*, with *kāñjī* in *vātaja vidradhi*, with cow's urine in *kaphaja vidradhi* or with wine is beneficial or else *śilājātū* should be used with the decoction prepared with the drugs capable of suppressing specific *doṣa*.

vi) *Pradhāna* (*mahiśākṣa*) *guggulu* should be used with *śuñhī* in *kaphaja vidradhi* and with *suradaru* in *vāta vidradhi* or else only *guggulu* can be used.

vii) Use of decoction of *triphalā*, *picumanda*, *madhuka*, *kañjūka*, *patola* each one *śṅga*, *trivrt* and *trāyaṇā* each one *karṣa* and *masūra* one *pala*, mixed with *ghṛta* cures abscess, or else decoction of *trāyaṇī*, *triphalā*, *nimba*, *kañjūka* and *madhuka* each one part, roots of *trivrt* and *patola* each four parts and husk free *masūra* eight parts mixed with *ghṛta* should be used.

viii) Decoction of *trāyaṇā* one *prastha*, pestled *muśī*, *kañjūka*, *tānalakī*, *trāyaṇā*, *candana*, *durālabhā*, *jīvanī*, *vīṛā* and *upala* each one *pala*, *ghṛta*, milk and juice of *āmālakī* each one *prastha* should be taken and *ghṛta* prepared. This is also beneficial in abscess.

ix) *Ghṛta* should be prepared with the decoction of *drākṣā*, *madhūka*, *khurjūra*, *ābhira*, *vidār*, *parūṣaka* and *triphalā* mixed with milk, juice of sugar-cane and *āmālakī* and pestled *abhyā*. When this *ghṛta* is cooled it should be mixed with honey and sugar in $\frac{1}{4}$ th quantity of *ghṛta*. This *ghṛta* is also beneficial.

Anuāsana and āsthāpana basti (uncting and evacuative enema)

Anuāsana (uncting) and *āsthāpana* (evacuative) *basti* (enemas) prepared with the decoction of *varuṇādi*, *uśakādi* and *virecanīya* group of drugs mixed with fat (oil) should be used.

Bloodletting or venesection

Bloodletting should be done either with leeches or horn. In *raktaja* and *pittaja vidradhi*

venesection of vein of middle arm (cubital vein) should be done.

Indication for use of poultice

In the abscess of *koṣṭha* (abdomen) in which suppuration has just begun and it is protruding out side, poultice should be applied.

Prevention of suppuration of abscess and effect of suppuration

All-out efforts should be made that the abscess does not suppurate, since it has the tendency of getting *vidāhi* (suppurated), hence, is termed as *vidradhi*. Once it is suppurated, treatment (result) is at the mercy of god. In comparison to other diseases the treatment of this disease should be started very quickly.

Examination of abscess for its suppuration and method of its drainage

When pain is localized, there is no pain on pressure around the abscess, burning sensation etc, have decreased and other clinical features suitable for instrumental interference have appeared, then the abscess should be incised and future treatment done like a wound.

In a case of *antarvidradhi* (internal abscess) after knowing about its suppuration by above clinical features or else when the pus is draining through upper or lower orifices, one should wait for ten or twelve days protecting the patient from complications.

Treatment of incompletely drained internal abscess

In a case of incomplete drainage of pus or presence of *kleda* (moisture), decoction of paste of *varuṇādi* group of drugs or *madhuśiṅgu* should be given with any one out of *kāñjī*, *surā*, *āṣava*, *maireya* or hot water for its proper drainage.

Rice gruel prepared with the decoction or paste of roots of above drugs (drugs of *varuṇādi* group or *madhuśiṅgu*) mixed with soup of *yava*, *kola* and *kulattha* should be given.

After ten days giving due consideration to strength of the patient, *śodhana* (cleansing/laxation) should be done with *tīlwaka* or *trāyaṇā* *ghṛta*.

After this purification *tīlwaka ghṛta* mixed with honey should be given repeatedly in small quantity.

Principles of treatment of vidradhi associated with prameha

In a case of abscess associated with *prameha* (diabetes) treatment of *prameha* should also be done.

सूतिकाञ्चर (Sūtikāñvara or puerperal fever)

ञ्चर का महत्त्व (Importance of fever)

सर्वधामेव रोगाणां ञ्चरः कष्टतमो मतः । तस्यादौ विधिं चक्ष्ये निदानाकृतिभेदतः ॥ ३८॥

(का० सं० खि० ११)

सभी व्याधियों में चक्र सबसे अधिक कष्टदायी होता है अतः सर्वप्रथम चक्र का निदान, स्वरूप तथा औषधि का चर्चन करेंगे।

As the fever is most troublesome in comparison to all other disorders, hence its etiology, clinical features and treatment would be described first.

चक्र के भेद (Classification of fever)

षड्विधस्तु प्रसूतानां नारीणां जायते चक्रः। निजानुविभागेन निदानं तस्य मे शृणु ॥ ३९॥
(का० सं० खि० ११)

निज (वातज, पित्तज, कफज एवं सन्निपातज) तथा अगन्तुज (स्तन्योरथ एवं ग्रहोरथ) के विभाग से प्रसूता स्त्रियों को ६ प्रकार के चक्र होते हैं अब उनका निदान मुझे सुने।

The puerperal woman suffers from six types of fevers classified under *mūja* (endogeneous i.e. *vāyija*, *pitta*, *kaphaja* and *sannipātija*) and *āgantuja* (exogenous i.e. *stanyoratha* and *grahoratha*) two major groups.

चक्र के निदान (Etiology of fever)

अ) सामान्य निदान (General etiology)

स्त्रीणां च विषमप्रजननात् प्रजातानां च मिथ्योपचारात् यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावाद्याशानिदानं द्वन्द्वनामयतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत् प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकुपितास्तथैवानुपूर्व्या चक्रमभिनिर्वर्तयन्ति ॥

(च० सं० नि० १/२८)

स्त्रीणामपप्रजानां प्रजातानां तथाऽहितैः। (सु० सं० उ० ३९/२२)

वेगसन्धारणाद्दोषाद् व्यापामदत्यसुकषयात्। शोकादत्यनिसन्तापात् कट्वस्त्रोष्णतिसेवनात् ॥ ४०॥

द्विवास्त्रजात् पुरोवातात् गुर्वभिष्यदिभोजनात्। सत्यागमाद् ग्रहबाधादस्त्रीणाददुष्प्रजायनात् ॥ ४१॥

चक्रः संजायते नार्याः षड्विधो हेतुभेदतः ॥ ४२॥ (का० सं० खि० ११)

महर्षि चक्र के द्वन्द्व एवं सांनिपातिक चक्र के निदानान्तर्गत लिखा है कि स्त्रियों में सामान्य रूप से प्रसव न होने अथवा प्रसव के बाद अनुचित आहार-विहार करने एवं पूर्वोक्त कारणों (दोष प्रकोपक विशिष्ट कारणों) के मिश्रित होने से निदानानुसार दो-दो या तीनों दोष एक साथ प्रकुपित हो उसी प्रकार का चक्र उत्पन्न कर देते हैं।

महर्षि सुश्रुत ने अगन्तुज चक्र के निदानान्तर्गत लिखा है कि असामान्यरूप से प्रसूता या सामान्य रूप से प्रजाला स्त्री को अहित सेवन से चक्र हो जाता है।

महर्षि कश्यप का कथन है कि वेगों को धारण करने, रक्षता, (रक्ष आहार एवं विहार से), व्यायाम, अत्यधिक रक्तस्त्राव, शोक, अग्नि के अत्यधिक संताप (के सेवन), कटु, अम्ल एवं उष्ण के अतिसेवन, दिवा-स्वप्न, पुरोवाता (पूर्व की ओर से आने वाली वायु का)-सेवन, गुरु एवं अभिष्यन्दी भोजन, सत्यागमन, ग्रहबाधा, अजीर्ण तथा प्रसव में कठिनाई या असामान्य प्रसव होने से स्त्रियों में हेतु-भेद के अनुसार ६ प्रकार का चक्र होता है।

The woman either having abnormal delivery or using non-congenial diet after normal delivery suffers from fever, is the opinion of Caraka and Susruta given while describing causes of fever due to two or three *dosas* and *āgantuja* fever.

Kāśyapa says that due to suppression of natural urges, dizziness (use of fat free diet or other dry measures), exercise (excessive), excessive haemorrhage (PPH), grief, use of ex-

cessive heat of fire, excessive use of bitter, sour and hot articles, day sleeping, use of wind blowing from eastern side, consumption of heavy and *abhiyanti* (moisture producing) diet, appearance of milk in the breasts, affliction by *grahas*, indigestion and difficult or abnormal labour the puerperal woman suffers from six types of fevers.

आ) सूतिका के सांनिपातिक चक्र के कारण (Causes of sannipātika puerperal fever)

स एव पूर्वरूपेषु व्यभिचीर्णो विरोधिभिः ॥ ४२॥

संसृष्टैः स्नेहशीतान्बुज्जनापानाशनादिभिः। सन्निपातचक्रो घरो जायते दुरूपकमः ॥ ४३॥

(का० सं० खि० ११)

इन्हीं पूर्वरूपों के साथ (पूर्वोक्त कारणों के साथ) विरोधी वस्तुओं का संयोग होने, स्नेह एवं स्नान, पान तथा अशन आदि में शीतान्बु का प्रयोग किए जाने से कठिनाता से चिकित्सा करने योग्य घोर सन्निपात चक्र हो जाता है।

तीनों दोषों के प्रकोप के सामान्य कारणों के वर्णन के अन्तर्गत लिखा है कि प्रसूता स्त्री में मैथुन, विषमशयन, प्रजागरण (रात्रिजागरण), दिवास्वप्न, चिन्ता, ईर्ष्या, तौल्य (जिह्वा-तौल्य) एवं कर्शन तथा दुष्प्रजाता में अनेकों प्रकार के व्यभिचार से तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं एवं चक्रादि अनेकों रोगों को उत्पन्न कर कष्ट देते हैं। सभी दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होने के कारण ये व्याधियाँ दुर्चिकित्स्य होती हैं।

Alongwith above mentioned causes if one uses incompatible things or articles contrary to each other in qualities, fairs or unctuous substances and cold water in the form of bath, drink and with diet, then suffers from severe *sannipātija jwara*.

While describing general etiology of vitiation of all the three *dosas*, Kāśyapa says that if puerperal woman indulges in coitus, consumes incompatible or abnormal eatables, does night awakening, day-sleeping, worry, jealousy, greed, and uses non-satisfying (emaciating) measures, or the woman having undergone abnormal/difficult labour, does various types of abnormal acts, then all the three *dosas* get vitiated and produce fever etc. various disorders, which are difficult to cure.

इ) प्रसूता में चक्रोत्पादक दोषों के प्रकोप का कारण (Factors responsible for vitiation of dosas which produce fever in a puerperal woman)

तस्या तौवाभिसर्वाभिः प्रतप्तं चाहन्श्रमैः। शैथिल्यं चागते देहेसंक्षुब्धेच्यन्तिदिदु ॥ ४४॥
क्लान्तेच्छिन्नियमाणेषु सारशूलेषु धातुषु। एकोऽपि दोषः कुपितः कृच्छ्रतो वहते महत् ॥ ४५॥
परिजीर्णं यथा वस्त्रं मलदिग्धं समन्ततः। क्लेशेन शोष्यते तन्नेः प्रदूष्य तत्तदाश्रयम् ॥ ४६॥
तथा शरीरं सूतायाः परितस्तुलं परितुलम्। भृशं दोषबलैर्दिग्धं क्लेशेन परिशोष्यते ॥ ४७॥
यथा च जीर्णं भवनं सर्वतः श्लथबन्धनम्। वर्धावातविक्रमपानामसहं स्यात्तथाविधम् ॥ ४८॥
तथा शरीरं सूतायाः खिन्नं प्रसवणश्रमैः। वातपित्तकफोत्थानां व्याधीनामसहं भवेत् ॥ ४९॥
दोषैरेव शरीराणि धार्यन्ते सर्वदेहिनाम्। तेषु क्षीणेषु सूताया चक्रः संतापलक्षणः ॥ ५०॥
देहं सत्तापयत्याशु शुक्लेभ्यन्मिवानतः ॥ ५१॥ (का० सं० खि० ११)

१. शरीरोपचारात् सूतानां मैथुनादिभ्रमजनात्। प्रजागतादिवस्त्रज्जान्तेत्यर्थोत्थैत्यर्थः ॥ १३॥

तथा दुःखप्रजानां व्यभिचारान् युष्मद्विषात् ॥ १४॥

त्रयो द्वेषाः प्रकुप्यन्ति॥ १८॥

ततो चक्रवद्वयो योगः पीडयन्ति भृशं नम्। सर्वदोषविरोधाच्च दुर्चिकित्स्यो महापादः ॥ १९॥ (का० सं० कल० ८)

उस स्त्री के लगातार तीव्र आविर्भावों के संवहन करने के श्रम के कारण शरीर में शिथिलता आ जाने, वायु आदि दोषों के संकुच हो जाने, इन्द्रिय-मार्ग (इन्द्रियों के कार्य) के क्लान्त हो जाने एवं शरीर की धातुओं के सार-शून्य (रक्त-स्त्राव के कारण) हो जाने के कारण एक भी दोष प्रकुपित हो जाने पर अत्यधिक कष्ट देता है।

जिस प्रकार चारों ओर से मल से आच्छादित जीर्ण वस्त्र जाली के द्वारा उसके आश्रय को देखते हुए बहुत ही कठिनाता से शुद्ध (स्वच्छ) होता है (अर्थात् असमर्थ विधि से शोधन करने से मल का आश्रय या कपड़ा ही फट जायगा) उसी प्रकार प्रसूता स्त्री का शरीर अत्यन्त कष्ट प्राप्त किए हुए एवं परिसृत (रक्त के निकल जाने) होने के कारण तथा दोषों के अत्यधिक बल (विकृति) तथा दियता के (शरीर में चिपके हुए होने) के कारण कठिनाता से शुद्ध किया जा सकता है।

जिस प्रकार पुराना मकान चारों ओर के वन्यन शिथिल हो जाने के कारण वर्षा, वायु एवं कम आदि को सहने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार प्रसूता स्त्री का शरीर प्रसव के श्रम एवं (रक्त के) स्त्राव के कारण वात, पित्त एवं कफोत्पन्न व्यर्थियों को सहन कर सकने में असमर्थ होता है।

सभी प्राणियों के शरीर को दोष ही धारण करते हैं उनके क्षीण होने पर प्रसूता स्त्री को संताप (उष्णता) लक्षण वाला चक्र हो जाता है और वह शरीर में उसी प्रकार शीघ्र ही सन्ताप उत्पन्न कर देता है जिस प्रकार शुष्क इन्धन में अग्नि।

As the body of puerperal woman becomes languid due to over exertion caused by continuous strong labour pains, *vāta* etc. *dōṣas* are irritated, *indriyas* (conative and cognitive organs) are exhausted and *dhrāvas* have loss of their *sāra* (essence) due to haemorrhage, hence even if one *dōṣa* gets aggravated it gives too much trouble.

As it becomes very difficult even for a expert person to clean an old extremely dirty cloth, because it gets tattered with slightest negligence, similarly it becomes very difficult to cleanse (purify) the body of puerperal woman, because due to haemorrhage the *dōṣas* are too much aggravated and adhered to the body parts.

As an old house can not withstand rain, wind and tremors due to looseness of its bonds, similarly the puerperal woman is unable to tolerate the diseases caused by *vāta*, *pitta* or *kapha* due to exhaustion of labour and blood loss.

The *dōṣas* sustain the body. In case of their decline the puerperal woman suffers from fever characterized with rise in temperature. The temperature shoots very quickly in the same way as the dry wood catches fire.

इ) चक्र के बल को बढ़ाने के कारण (The causes of increase or aggravation of fever)

शीतोपवास व्यायाममायामसहितारणम् । तन्देहुरेवनं चैव क्षिप्रं चक्रबलावहम् ॥ ७६ ॥

(का० सं० खि० ११)

शीत, उपवास, व्यायाम, शकवट, अर्धित भोजन तथा च्चरोत्सादक नितानों का सेवन करने से चक्र के बल में शीघ्र ही वृद्धि हो जाती है।

Due to use of cold articles, fasting, exercise, "iredness, consumption of non-congenial food and use of other things capable of causing fever, the virulence of fever increases immediately.

लक्षण (Clinical features)

अतः पर चक्राणां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते । (का० सं० खि० ११/५४)

अब चक्रों के लक्षण कहे जाएंगे।

Now the clinical features of different types of fevers would be described.

अ) वातचक्र के लक्षण (Clinical features of fever due to *vāta*)

विषमोष्णोऽङ्गमर्दश्च जुष्मण्यु रोमहर्षणम् ॥ ५४ ॥

कषायविरसास्रावत् शीतद्विषोष्णकामते । दन्तहर्षः प्रलापश्च शुष्कोद्वाराः प्रजागरः ॥ ५५ ॥

आभ्यामङ्गसङ्कोचो वातचक्रनिदर्शनम् ॥ ५६ ॥ (का० सं० खि० ११)

विषम ऊष्ण (शरीर के किसी स्थान में अधिक किसी में कम उष्णता या क्षण में अधिक क्षण में कम ताप); अङ्गमर्द, जुष्म, रोमहर्ष, मुख में कषाय स्वाद या विरसात, शीत पदार्थों से द्वेष, उष्ण पदार्थों की इच्छा, दन्तहर्ष, प्रलाप, सूखे उद्वारा (बिना वमन के), प्रजागरण (निद्रानाश), आभ्याम तथा अङ्गों में संकोच आदि वातजन्य (सूक्तिका) चक्र के लक्षण हैं।

Irregular temperature (sometimes or in some body parts low, sometimes or in other body parts very high), bodyache, yawning, horripilation, tastelessness or astirgent taste of mouth, disliking for cold and desire for hot articles, morbid sensitivity of the teeth, delirium, dry eructation (without association of vomiting), insomnia, flatulence and feeling of contraction/spasm of body parts etc. are the clinical features of fever due to *vāta*.

आ) पित्तचक्र के लक्षण (Clinical features of fever due to *pitta*)

तृष्णा दाहः प्रलापश्च वमशुः कटुकास्यता ॥ ५६ ॥

पीतास्रनखदन्ताक्षिविण्मूत्रात् च लक्ष्यते । कण्ठस्य शोषः सर्वं च प्रदीप्तमिव मय्यते ॥ ५७ ॥

भ्रमः शीतोभिस्तापश्च पित्तचक्रनिदर्शनम् ॥ ५८ ॥ (का० सं० खि० ११)

तृष्णा, दाह, प्रलाप, वमन, मुख का कटुआपन, मुख, नख, दन्त, अक्षि, मल तथा मूत्र का पीला दिखना, कण्ठ का सूखना, सभी कुछ जलता हुआ प्रतीत होना, भ्रम तथा शीतोभिस्ताप आदि पित्तचक्र (सूक्तिका) के लक्षण हैं।

Thirst, burning sensation, delirium, vomiting, bitter taste of mouth, yellow appearance of face, nails, teeth, eyes, feces and urine, dryness of throat, feeling as if every thing is burning, giddiness, and desire for cold things are the clinical features of fever due to *pitta*.

इ) श्लेष्मचक्र के लक्षण (Clinical features of fever due to *śleṣmā*)

उष्णामिकांमता कासः शिरोरुक्पात्रागौरवम् ॥ ५८ ॥

मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुक्लमूत्रपुरीषता ।

निद्रा तन्त्रीहिमद्वेषः (तन्त्रा हिमद्वेषः-शुष्णोपा०) श्लेवनं मसृगास्यता ॥ ५९ ॥

गात्रसादोऽत्रविद्वेषः कफचक्रनिदर्शनम् ॥ ६० ॥ (का० सं० खि० ११)

उष्ण पदार्थों की इच्छा, कास, शिरःशूल, शरीर में भारीगन, मन्द ऊष्ण (अपेक्षाकृत कम तापमान वृद्धि), प्रतिश्याय, मूत्र एवं पुरीष की स्वेता, निद्रा, तन्त्रा, शीत-विद्वेष (शीत पदार्थों की अनिच्छा), श्लेवन, मुख में मोटेपन की अनुभूति, गात्र-साद तथा अत्र-विद्वेष आदि कफचक्र के लक्षण हैं।

Liking for hot things, cough, headache, heaviness of body, comparatively low grade

temperature, coryza, white colouration of urine and feces, sleepiness, drowsiness, dislike for cold articles, repeated spitting, sweet taste of mouth, exhaustion of body, hatred for food etc. are clinical features of fever due to *kapha*.

ई) सांनिपातिक चक्र के लक्षण (Clinical features of fever due to *sannipāta* or all the three dosas)

मधुः शीतं मुहुर्दाहो गुरुलूष्णा समोऽसमः ॥ ६०॥

कृच्छ्रिणमूत्रवातलं वाताङ्गान्याभिमसञ्जन्म् (वातादाऽभिमसञ्जन्म् शु० पा०) ।

दाहसृष्णाप्रलापश्च पित्ताक्षिप्तचितता ॥ ६१॥

गुरुत्वं कण्ठसंश्लेषः कफाच्च प्रतिशीतता (पतिशीतता शु० पा०) ।

संनिपातचक्रस्यैतल्लक्षणं समुदाहृतम् ॥ ६२॥ (का० सं० चि० ११)

क्षण में शीत, क्षण में दाह, क्षण में ऊष्मा (शीत में) तथा कभी सम एवं कभी विषम अग्नि; वायु के कारण मल, मूत्र तथा वायु के निकलने में कठिनाई एवं आन्त्रों में पीड़ा; पित्त के कारण दाह, तृष्णा, प्रलाप तथा चित्त की विक्षिप्तता; कफ के कारण गुरुत्व, कण्ठ-संश्लेष तथा सर्दी लगना आदि संनिपात चक्र के लक्षण कहे गए हैं ।

In a moment feeling of coldness while at other the burning sensation, frequent rise and fall in temperature, sometimes normal sometimes abnormal *agni* (fever and digestive power); difficulty in excretion of feces, urine and flatus alongwith pain in abdomen due to vitiation of *vāyu*; due to vitiation of *pitta* burning sensation, thirst, delirium and instability of mind; heaviness, feeling of obstruction in throat and shivering etc. due to vitiation of *kapha* are the clinical features of fever due to *sannipāta* or all the three *dosas*.

उ) सत्योत्पत्ति जन्य चक्र के लक्षण (Clinical features of milk fever)

सत्यावतरणो चैव च्युरो दोषैः प्रवर्तते । (सु० सं० उ० ३९/२२)

तृतीयोऽह्नि चतुर्थे वा नार्योः सत्यं प्रवर्तते । पयोवह्निं स्रोतांसि सवृत्ताभ्यधृयेत् ॥ ६३॥

करोति सत्ययोः सत्यं पिपासां हृदयद्रवम् । कुक्षिपार्श्वकटीशिरःपङ्कजं शिरःकजम् ॥ ६४॥

एतत् सत्यागमोत्पत्त्य च्युरस्योक्तं स्वलक्षणम् । स हि पीयूषसंयुद्धौ क्रममात्रेण तिष्ठति ॥ ६५॥

(का० सं० चि० ११)

महर्षि सुश्रुत ने सामान्य चक्र के वर्णन के अन्तर्गत लिखा है कि स्त्रियों को सत्य के अवतरण के समय दोषों के (विकार के) कारण चक्र हो जाता है ।

(प्रसवोपरान्त) तीसरे या चौथे दिन स्त्रियों को सत्य की प्रवृत्ति होती है । (यह सत्य) सत्यावह स्रोतों को प्राप्त होकर प्रभाव डालता है (स्रोतों से का अवरोध करता है) तथा स्तनों में सत्य, पिपासा, हृदयद्रव (हृदयगति का तीव्र होना), कुक्षि, पार्श्व एवं कटि में यूल, अङ्गमर्द, शिरःयूल आदि उत्पन्न करता है, ये सत्य के आगम के कारण उत्पन्न चक्र के लक्षण हैं । दूध के शुद्ध हो जाने पर (निकल जाने पर) वह चक्र क्रमशः शान्त हो जाता है ।

Sūśruta has included appearance of milk in the breasts as a causative factor in the description of fever in general.

Kāśyapa opines that on third or fourth day the milk starts appearing in the breasts. This milk reaches the *stanyavahastrotasa* (breasts), influences them and produces stiffness of breasts, thirst, *hridayadrava* (tachycardia), pain in abdomen, flanks and sacral region, bodyache and headache. These are the symptoms of milk fever. The fever subsides as soon as the milk is properly drained.

ऊ) ग्रहोत्पत्ति चक्र के लक्षण (Clinical features of fever caused by *grahas*)

ग्राहलोकितग्रासवाताघाताधूनमैः । च्युरीते चेत् प्रसूता स्त्री तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ६६॥

उद्वेगको निष्ठुरनं चक्षुषो विषमः श्रमः । कर्मणं हस्तेनेत्राणां हरिद्रमुत्रवेता ॥ ६७॥

क्षणेन प्रयावताऽङ्गानां क्षणेन च सर्वाणाम् । सुषोषः सह ... कोशः केयलुञ्जन्म् ॥ ६८॥

पवनचरलूपाणि भूयिष्ठानि करोति च । विधिग्रहोऽप्येतद्विहितः क्रमो यश्चानिलच्युरे ॥ ६९॥

(का० सं० चि० ११)

ग्रहों के देखने, भय, वात, आघात अथवा कर्मण से जो प्रसूता स्त्री को चक्र हो जाता है उसके लक्षण कहूँगा—
उद्वेगन (प्रेर शरीर का कँपना), विक्षाना या दीर्घ श्वास लेना, नेत्र-विषम, श्कावट, हाथों एवं नेत्रों में कर्म, मुख तथा नेत्र का पीला हो जाना, क्षण में अङ्गों में श्थमता एवं दूसरे ही क्षण सामान्य वर्ण का हो जाना, मलीभौति जान रहने हुए भी चिल्लाना एवं केयलुञ्जना तथा अन्य वातचक्र के लक्षणों से विशिष्ट रूप से आक्रान्त होती है । इसमें ग्रह नाशक तथा वातचक्र-नाशक विधि हितकर हैं ।

Clinical features of fever arising due to sight (effect) of *grahas*, fear, *vāta*, trauma and shaking or trembling are as follows—

Tremors of whole body, crying or deep breathing, abnormal visual perception, tiredness, tremors/twitching of hands and eyes, yellowishness of face and eyes, quick alteration in body complexion into blackness or normal colour, inspite of full consciousness crying and plucking of hair and other features of fever caused by *vāta* are the clinical features of fever caused by *grahas*. In this disease measures to pacify *grahas* and other treatment prescribed for fever due to *vāta* should be used.

चिकित्सा (Treatment)

चिकित्सा-सिद्धान्त (Principles of treatment)

१) सामान्य चिकित्सा-सिद्धान्त (General principle of treatment)

तद्धेतुमात्रवृद्धानां दोषाणां तु यथोच्छ्रयम् ॥ ५१॥

कुयार्दुपुण्ड्रं धीमान् धातूनां च प्रसादनम् ॥ ५२॥

स्वेदोपपत्तर्पणं युक्त्या पाचनौषधसेवनम् । कषायोऽप्यङ्गनं सर्पिचूर्णं परमो विधिः ॥ ७५॥

(का० सं० चि० ११)

बुद्धिमान् (वैद्य) साधारण कारणों से भी बड़े हुए दोषों के अनुसार उपयमन करे तथा धातुओं का प्रसादन करे ।

युक्तिपूर्वक प्रयोग किया गया स्वेद, अपतर्पण (लंबन), पाचन औषधियों का सेवन, कषाय-प्रयोग, अप्यङ्गन एवं सर्पि-प्रयोग चक्र को नाश करने की विशिष्ट विधि है ।

अन्तर्गत आचार्य ने वातादि दोषों के बल के क्षीण होने के कारण शोषन होने में कठिनाई का वर्णन किया है^१ ।

The wise physician should pacify the *dosas* vitiated due to even very simple reason, giving due consideration to the quantum of aggratation and should also purify or gratify the *dhātus*.

१. का० सं० चि० ११/४० (पृ० ५८७, ५८८)

Methodically used sudation, fasting, use of digestive drugs or measures, drugs, decoctions, massage and *ghrita* cure fever.

Difficulty in cleansing the body due to decreased strength of *doshas* has been described earlier (page 588).

२) स्त्रीरोगाभिष्यन्दी आदि स्त्री के च्वर में चिकित्सा सूत्र (*Principles of treatment of woman having abhishyandā i.e. moisture due to kapha etc.*)

स्त्रीरोगाभिष्यन्दी स्त्रुतामक्तिशामल्यनिःश्रुताम् । विदग्धभक्तां निम्बधं च लङ्घनेनोपपादेत् ॥ ७० ॥
लङ्घितायाश्च मण्डादिः..... ॥ ७२ ॥ (का० सं० खि० ११)

स्त्रीरोगा (के प्रकारों) के कारण आभिष्यन्दी, स्त्रुता (अधिक), आम के क्लेद से युक्त, अल्प निःश्रुता (जिसे रक्त का स्राव अधिक न हुआ हो), विदग्धभक्ता (जिसका भोजन पचता न हो या विदग्ध हो जाता हो) तथा निम्बध स्त्री की लंघन के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए । लंघन करने के बाद मण्डादि का प्रयोग करना चाहिए ।

The puerperal woman suffering from fever and having *abhishyandā* (excessive moisture) due to vitiation of *kapha*, obesity, moisture due to *āma*, and who has not bled much, whose food does not get digested and has unctuous body should be treated with fasting. After observance of fasting scum of boiled rice should be prescribed.

३) रुक्ष आदि शरीर की सूतिका का चिकित्सा सूत्र (*Principles of treatment of woman having dry body etc.*)

रुक्षं निःश्रुताकां च कृशां वातज्वादिताम् । क्षुत्तुणाभिहतां कलानां शमनोपपादेत् ॥ ७१ ॥
तत्प्रासतदरेवेह पेयादिः क्रम इष्यते । लङ्घितायाश्च मण्डादिरित्येष द्विविधः क्रमः ॥ ७२ ॥
(का० सं० खि० ११)

रुक्ष शरीर वाली, जिसको रक्त स्राव (अत्यधिक) हुआ हो, कृश, वातज्वर से पीड़ित, भूख-व्यास से आक्रान्त तथा कलान्त स्त्री की शमन (औषधियों) द्वारा चिकित्सा करें । उसे उसी दिन से पेयादि क्रम से भोजन कराएँ ।

लंघन कराई गई स्त्री को मण्डादि क्रम से पच्य दें । यह दो प्रकार का क्रम (पच्य) वर्णित है ।

The woman whose body is dry, has bled profusely, is emaciated, suffering from fever due to *vāta*, hungry, thirsty and exhausted should be treated with pacifying or suppressive measures and be prescribed diet from the same day following *peyādi krama* (specific sequence of diet i.e. first liquid, then semisolid then solids etc.).

The woman who has been fasting should be given scum of boiled rice etc. in serial order.

४) पेयादि प्रयोग की उपादेयता (*Benefits of peya or tisane and maṇḍa or scum etc*)

पेया हि दीपयन्त्यनिं धातून् संशमनयति । गर्भदोषावशेषघ्नो मण्डो दोषविपाचनः ॥ ७३ ॥
तस्मात् पेया च मण्डश्च क्रमादौ विहितौ हितौ । अकृताश्च कृतरचैव द्विस्त्रिपूर्वसौ तथा ॥ ७४ ॥
(का० सं० खि० ११)

पेया अग्नि को दीप्त करती है, धातुओं का संशमन करती है, विशेष कर गर्भ-दोषों का नाश करती है, मण्ड दोषों का पाचन करता है, अतः पेया एवं मण्ड का क्रम से प्रारम्भ में प्रयोग हितकर माना गया है तथा दो-तीन दिन तक अकृत (असंस्कृत) तथा कृत (संस्कृत) यूथ एवं मांसस का प्रयोग करना चाहिए ।

The *peya* (tisane) enhances the digestive fire, pacifies the *dhatūs*, specially removes the *garbha-doshas* (abnormalities caused by fetus or delivery). The *maṇḍa* (scum of boiled rice) digests the *doshas*. Due to these reasons initial use of *peya* and *maṇḍa* is said to be beneficial. For two or three days medicated or non-medicated soups (of cereals) and meat-soups should also be prescribed.

५) कषाय-प्रयोग का काल (*Period of use of decoctions*)

संसर्गाचिते दोषे च्वरे च मुदुतां गते । पञ्चाहात् सप्तमाद्या कषायमवचारयेत् ॥ ८३ ॥
पाचनीयं तु पञ्चाहात् सप्ताहादनुत्तोमिकम् ॥ ८४ ॥ (का० सं० खि० ११)

संसर्ग से (संसर्जन क्रम में पेयादि प्रयोग से) दोषों का पचन हो जाने पर तथा च्वर के मुदु हो जाने पर पाँच या सात दिन के बाद कषाय का प्रयोग करें । पाँच दिन के बाद पाचनीय तथा सात दिन के बाद अनुत्तोमिक (कषाय) का प्रयोग करना चाहिए ।

Once with *samsarjana krama* (regulated use of diet i.e. liquid-semisolid-solid or *peya-maṇḍa-vilepi* etc.) the *doshas* are digested (*āma* is digested) and fever has decreased, then after five days digestive and alter seven days *anulomaka* (carminative or excretory) decoctions should be used.

६) कफपित्त च्वर का चिकित्सा सूत्र (*Principles of treatment of fever due to kapha with pitta*)

कफपित्तच्वरे दद्यात् पञ्चाहे शमनौषधम् ॥ ८४ ॥
स्वभावतैश्चपादलेन कालेन परिपच्यते । दुर्बलत्वाच्च धातूनां च्युतत्वादामयस्य च ॥ ८५ ॥
(का० सं० खि० ११)

कफपित्त च्वर में पाँचवें दिन संशमन औषधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव (औषधियों के स्वभाव) से तीक्ष्णता, धातुओं के दुर्बल तथा व्याधि के (विशेषकर आमदोष के) च्युत होने के कारण (घटने के कारण) दोष अल्प-काल में ही पच जाते हैं ।

In *kaphapittaja* fever pacifying drugs should be used from fifth day. Due to sharpness of action of drugs, weakness of *dhatūs* and decline in disease specially *āma dosha*, the *doshas* get digested in very short time.

७) वातज्वर का चिकित्सा सूत्र (*Principles of treatment of fever due to vāta*)

वातज्वरे तितेऽप्यङ्गैस्तथैव रसभोजनैः । पक्वाण्यस्ये विमले विदग्धादानुत्तोमिकम् ॥ ८६ ॥
भोजयेद्भक्ष्यं चाप्यन्नं तनुभिर्जाङ्गितैः रसैः ॥ ८७ ॥ (का० सं० खि० ११)

वातज्वर के अप्यङ्ग एवं रस (मांसस) के भोजन से शांत हो जाने तथा पक्वाण्यस्य दोषों (वायु) के विमल (शान्त) हो जाने पर अनुत्तोमिक कषाय तथा लघु अन्न को जाङ्गल प्राणियों के फले मांसस के साथ भोजन के लिए देना चाहिए ।

Once the fever due to *vāta* is pacified by use of massage and meat-soup and *doshas* situated in *pakvāṇya* (large bowel) are suppressed, the *anulomika* (carminative) decoctions should be used. Light cereals mixed with liquid meat soup of wild animals should be prescribed in diet.

८) वातपित्तसक चक्र का चिकित्सा-मूत्र (Principles of treatment of fever due to vāta with pitta)

यक्ष नैवं शमं याति वातपित्तसकचक्रो चक्रः ॥ ८७॥

सर्पिलं शमयेदाशु दावान्निमित्तं तोयदः । विमलेऽग्नौ मूदौ (व्याधौ) सर्पिरिव परायणम् ॥ ८८॥

स्नेहव्याघ्रासु भूयिष्ठं व्याघरो दुष्प्रजातः ॥ ८९॥ (का० सं० खि० ११)

जो उपर्युक्त विधि से शान्त न हो वह वातपित्तसक चक्र होता है, उसे घृत (प्रयोग) उसी प्रकार शीघ्र ही शान्त कर देता है जिस प्रकार बादल दावागिन को ।

अग्नि के विमल (शुद्ध) होने तथा व्याधि के मूद होने पर घृत ही मुख्य औषधि है । दुष्प्रजात की व्याधियाँ अधिकशतः घृत प्रयोग से शान्त होती हैं ।

The fever which is not cured with above described measures is due to vāta and pitta together. It gets cured with the use of *ghrita* in the same way as fire of forest subsides with rain.

Once the digestive fire gets purified and disease subsides, use of *ghrita* is the main treatment. Most of the diseases of woman having undergone abnormal labour get cured by use of *ghrita*.

९) साविप्रगतिक चक्र में चिकित्सा-मूत्र (Principles of treatment of fever due to samāpāda)

सन्निपातचक्रे नार्या मारते च बलीयासि ॥ ८९॥

संस्कृतं रसयूषाभ्यां पुराणं संसिच्यते ॥ ९०॥ (का० सं० खि० ११)

सन्निपातिक चक्र तथा वायु के बलवान होने पर संस्कृत मंसंस तथा यूष एवं पुराने घृत का प्रयोग करना चाहिए ।

In *samāpāda* fever, specially when *vāyu* is strong, medicated soup of meat or cereals and old *ghrita* should be used.

सूतिका में शोथन कर्मों का निषेध या प्रयोग (Indications and contraindications for use of cleansing measures in a puerperal woman).

१) सूतिका को वमनादि निषेध का कारण (Reasons of contraindications for use of emesis etc. cleansing measures in a puerperal woman)

गर्भाशये च्युते नार्या दोषास्तदनुगामिनः । च्यवन्ति तस्माद्गमनं नस्यं बस्तिवैचनम् ॥ ७७॥

न कार्यमल्पदोषायाः शरीरं परिसंस्थिते । तदेव युक्तैः कार्यं वीक्ष्य दोषबलाबलम् ॥ ७८॥

वमनं वा विरेकं वा तीक्ष्णं तीक्ष्णौषधान्वितम् । न ह्यतिच्युतदोषाया च्यतितायाः प्रशस्यते ॥ ७९॥

संतसे तूष्णता देहे धातवः परिपचिताः । भूयसीक्ष्णौषधं प्राप्य गच्छेयुर्मितां गतिम् ॥ ८०॥

(का० सं० खि० ११)

स्त्री के गर्भाशय में च्युत होने से (प्रसव-काल एवं प्रसवोपरांत रक्त के गर्भाशय मार्ग से च्युत या खिंचा हो जाने से) उसका अनुगमन करते हुए दोष भी च्युत (शरीर से च्युत) हो जाते हैं अतः वमन, नस्य, बस्ति तथा विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोष अल्प मात्रा में ही शरीर में स्थित होते हैं । उनके (दोषों के) बलाबल को देखकर युक्तिपूर्वक ही कर्म (शोथन कर्म) करना चाहिए ।

चक्र से पीड़ित एवं दोषों के अत्यधिक च्युत हो जाने पर तीक्ष्ण औषधियों से युक्त तीक्ष्ण वमन एवं विरेचन नहीं देना चाहिए । ऊष्मा (चक्र की) से शरीर के संतप्त हो जाने से घातुओं का परिष्कार हो जाता है, पुनः तीक्ष्ण औषधियों

(वमन एवं विरेचनार्थ प्रयुक्त) के प्रयोग से (घातुओं) अम्लित (अममान्) स्थिति को प्राप्त हो जाती है ।

Due to excretion of blood through uterus after delivery, the *dosas* following it also get dropped or trickle down: emetics, stimulatory drugs (suberthines), enemas and purgatives should not be prescribed, because the *dosas* in the body are comparatively in lesser amount. Giving due consideration to the strength of *dosas* these cleansing measures should be used very judiciously.

The woman suffering from fever and having lost sufficient amount of *dosas* should not be prescribed sharp emetics and purgatives with pungent drugs. *Paripāka* (metabolic changes) of *dhātus* occur due to heat generated by fever in the body and use of pungent drugs as emetics or purgatives makes these *dhātus* abnormal.

२) सूतिका चक्र में वमनादि स्थिति (Indications for use of emetics in a woman suffering from puerperal fever)

उत्क्रियमाणो हृदये कफे चाप्यग्नि स्थिते । कफचक्रे क्षमे देहे विदध्याद्गमनं मूदु ॥ ८१॥

(का० सं० खि० ११)

कफ चक्र में हृदय का उत्क्रिय होने, कफ के वक्षस्थल में स्थित होने तथा शरीर के (वमन को सहन करने में) समर्थ होने पर मूद वमन देना चाहिए ।

Mild emetics should be prescribed in the fever due to *kapha* associated with disquietude of heart (nausea) alongwith situation of *kapha* in chest region and the body being capable of tolerating emesis.

३) सूतिका चक्र में नस्यार्ह स्थिति (Indications for use of suberthines in puerperal fever)

अरुचौ कण्ठसंश्ले कफे चैव शिरोगते । अशक्त्यमाने कवले नस्यं तत्र विधाययेत् ॥ ८२॥

(का० सं० खि० ११)

अरुचि तथा कण्ठश्लेष् होने, कफ के शिरोगत हो जाने तथा कवले के घ्राण में असमर्थ होने पर नस्य का प्रयोग करना चाहिए ।

When the woman has anorexia and feeling of obstruction in throat, the *kapha* has reached head and the woman is unable to retain mouthful of medicated water (*kawala*), she should be prescribed stimulatory drugs.

सूतिका चक्र की विशिष्ट चिकित्सा (Specific treatment of puerperal fever)

अ) सूतिका के वातचक्र की चिकित्सा (Treatment of fever due to vāta of a puerperal woman)

अब मैं वातचक्र की चिकित्सा का वर्णन करूँगा ।

Now I shall describe the treatment of fever due to vāta.

(अ १) स्वेद (Sudation)

क्रब्धद-मांस (मांसभक्षी पशु-पक्षी का मांस), धान्य, माष, तिल, यव, दशमूल, अफामर्ग, भपटी, एण्ड, आटरूषक,

१. तत्र वातचक्र तावत् प्रवक्ष्यामि चिकित्साम् ॥ ९०॥ (का० सं० खि० ११)

अक्षंघा, श्वदंश तथा वंशपत्र को एकत्र कर कपीष (गोबर चूर्ण) एवं अम्ल (कांजी) मिलाकर दिया गया संकरस्वेद वात-ज्वर को प्रारम्भिक अवस्था में लाभदायक है^१।

Saṅkara type of sudation prepared with meat of carnivorous animals, cereals, *māṣa*, *nīla*, *yawa*, *dāṣamīla*, *apāmārga*, *bhañi*, *eranda*, *dāraṣūka*, *dāṣagandhā*, *śwadamṣṭrā* and leaves of *vamśa* mixed with powdered cow-dung and pested with *kāñjī* is beneficial if given in the beginning of fever due to *vāta*.

(अ २) वातज्वर का वेपथु शान्त न होने पर बाह्य प्रयोग (External application in convulsions associated with fever due to *vāta*)

यदि वात की प्रधानता से उत्पन्न वेपथु शान्त न हो तो निम्न औषधियाँ प्रयोग करें-

१) उष्ण तैल से भली भाँति अभ्यङ्ग करके सुतरा का घूँस तथा सर्पान्म द्रव्यों को काँजी में पीस कर सुखोष्ण लेप करें^१।

२) रसोनाक, वासा, वंश, तर्कारी, एण्ड, अपामार्ग, काश्मरी तथा भङ्ग को उष्ण काँजी में डालकर अवगाहन करायें।

३) सूक्ष्मपूर्वक अवगाहन को हुई स्त्री को असन्दी (गद्दी), अजिन (चर्मच्छद), कन्बल आदि से भली भाँति आश्रय करके (सुक्ष्मपूर्वक चर्मच्छद बिछी हुई गद्दी के ऊपर कन्बल से ढक कर बिठाकर) कुछ एवं गुग्गुलु में घृत मिलाकर घूँस करके उष्ण अन्न-पान का प्रयोग करें^१।

If convulsions associated with fever due to *vāta* do not subside, then following treatment should be given—

i) After giving good massage with hot oil, fumiṅgation with *suradāru* should be done and lukewarm paste of *sarvagandhā* drugs (the drugs having fragrance i.e. *ela* etc.) with *kāñjī* should be anointed.

ii) Bath (ub-bath) with hot *kāñjī* mixed with decoction of *śyonāka*, *vāṣā*, *vamśa*, *tarkāra*, *eranda*, *apāmārga*, *kāśmārī* and *bhañga* should be given.

iii) Fumiṅgation with *gugguḷu* mixed with *ghṛta* should be given to the woman having received pleasuring tub bath then wrapped with a blanket and seated over a skin-covered seat, this should follow the use of hot eatables and drinkables.

(अ ३) वातज्वरहर तैल का आन्तर एवं बाह्य प्रयोग (Internal and external use of oil capable of curing fever due to *vāta*)

तैल के वर्णन में कहाँ पर भी यह निर्देश नहीं है कि इसका प्रयोग आन्तर होगा या बाह्य, अतः यह अर्थ कर

१. क्रयान्तां च मांसानि धान्यमाषाणि चानाः । दशमूलमपामार्गं भण्ड्येण्डाटलकाः ॥ १९॥

अक्षंघां श्वदंशं च वंशपत्रं च संहेतः । इत्येकं संकरस्वेदः सकरीषोऽप्यस्तयुतः ॥ २०॥

वातज्वरज्वरादः स्यात् संसर्गादौ सुखान्नहः ॥ २३॥ (का० सं० खि० ११)

२. स चैवैतोलज्जन्वाच्च वेपथुर्नोपशान्तिः । स्वप्यकामुष्णतैलेन धूपयेत् सुतराणा ॥ १०६॥

सुखोष्णैरन्तर्पिदैश्च सर्पान्मन्त्रैः प्रलेपयेत् । रसोनाकवासंशानां तर्कारीण्डास्तथा ॥ १०७॥

अपामार्गस्य काश्मर्या पङ्गोष्णालेऽवगाहयेत् । सुखान्नाढ्यामक्षतां मासाद्याजिनकन्बलैः ॥

(सुखान्नाढ्यामक्षतामासाद्याजिनकन्बलैः शु० पा०) ॥ १०८॥

हुङ्गुगुग्गुलुं घृतमिश्रिण धूपयेत् । उष्णानि चान्नपानानि ॥ १०९॥ (का० सं० खि० ११)

सकते हैं कि इस वातज्वर-नाशक तैल का नस्य, बलित, अभ्यङ्ग एवं पान सभी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ।

दोनों पञ्चमूल, वृश्चीन, एकेवीका (त्रिवृत् या पाठा या गंधर्प), पुनर्ववा, महस्वर्वाय, नादेयी, शतर्वीर्या, शतावरी, विश्वदेवा (गाङ्गेरुकी या बला), शुक्रानस्य, सहदेवी, नाकुली, रास्ना, अन्नान्मा, पूतीक, देवबला, देवताडक, दोनों बला तथा हंसपादी का क्वाथ बनावे तथा कृष्ण अगर, व्याघ्रनख, शतपुष्पा, पलङ्काया, कायस्था, वयस्था, चोर्क, जटिला, जटा, अपेराक्षसी, वृक्षगुहा, महा (?) , उग्रलेपिका (?) , हेरेणु, हेमवती (रज्जो ववा), कैरव, सुवहा, ववा, वृश्चिकाली, भार्गी, रयामा तथा शिथु के कल्क के साथ (उपयुक्त क्वाथ मिलाकर) तैल का पचन करें, यह तैल वातज्वर नष्ट करता है^१।

Since in the description, mode of administration of oil has not been prescribed, hence it can be presumed that it has to be used externally and internally both.

Decoction of both *pañcamūla*, *vṛścīva*, *ekesīkā*, *punarnavā*, *sahasraṅgāyā*, *nādeyī*, *śatavīryā*, *śatāvharī*, *vīśvadevā*, *śukranasā*, *sahadevī*, *nākulī*, *rāsna*, *ajñāgandhā*, *pūtīka*, *devābhā*, *devatāḍaka*, both *balās* and *haṁsapādī* should be prepared. In this decoction paste of black agar, vyāghranakha, śatapuspā, palāṅkāyā, kāyasthā, vāyasthā, corakā, jatīlā, jāṭā, apēraśkāsī, vṛkṣaguhā, mahā, uśīralomīkā, hareṇu, hemavatī, kairavā, suvahā, vacā, vṛścīkalī, bhārgī, śyāmā and śīgṛu should be mixed and with this mixture oil should be prepared. This oil cures fever due to *vāta*.

(अ ४) आन्तर प्रयोग के लिए औषधियाँ (Oral medicines)

१) बृहत्पञ्चमूल अथवा त्रिवृत्तगन्धा के क्वाथ में सैन्धव मिलाकर पान करना चाहिए^१।

२) रास्ना, सरल, देवबला, यष्टीमधु, बृहती, सरल, दारु, भार्गी, वरुणक, एण्डमूल, रास्ना तथा वृश्चिकाली का क्वाथ बनाकर क्वाष्ण पान करना चाहिए यह वातज्वर-नाशक है, बाद में त्रिवृत्तमूल से सिद्ध जल का पान करना चाहिए^१।

३) यव, कोल, कुलत्थ तथा दोनों पञ्चमूल के क्वाथ में दही, यवक्षार, चव्य, चित्रक, नागर तथा पिप्पली मिला कर सिद्ध किए हुए घृत का पान ज्वरहर, वातरसैष-जन्म विबन्ध तथा ग्रहणी (व्याधि) नाशक एवं अग्नि-दीपक है । (इसके बाद) रयामा एवं तिलचक से सिद्ध घृत से विरेचन करायें^१।

i) Decoction of *bṛhatpañcamūla* or *vīdarīgandhā* mixed with rock salt should be taken orally.

ii) Lukewarm decoction of *rāsna*, *saralā*, *devābhā*, *yaśṭīmadhū*, *bṛhātī*, *saralā*, *dāru*,

१. द्वे पञ्चमूलौ वृश्चीनमेकवीकां पुनर्ववा ॥ १३॥

सहस्वर्वाय नादेयी शतर्वीर्या शतावरीम् । विश्वदेवां शुक्रानस्य सहदेवां समकुलीम् ॥ १४॥

रास्नाञ्जान्मन्त्रे पूतीकं देवबलां देवताडकम् । बले द्वे हंसपादी च क्वाथार्थमुपसंहेतु ॥ १५॥

कृष्णगुल्फं व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कायाम् । कायस्थां च वयस्थां च चोर्कं जटिलां जटाम् ॥ १६॥

अपेराक्षसी यक्षगुहां (वृक्षगुहा-शु० पा०) महोदलीमिकाम् । हेरेणुकां हेमवतीं कैरव सुवहां ववाम् ॥ १७॥

वृश्चिकाली च भार्गी च रयामा शिथुं च कल्कयः । सहस्र तैलं विपचिद्विज्वरनिर्हणम् ॥ १८॥ (का० सं० खि० ११)

२. महतः पञ्चमूलस्य विवेदं क्वाथं ससैन्धवम् । पेये विदारिगन्धया निष्काशे वा ससैन्धवः ॥ १९॥

रास्नी सरलदेवबृहतीभ्युक्तसंयुताम् । बृहती सरल दारु भार्गी वरुणकं तथा ॥ २०॥

एण्डमूलं रास्ना च वृश्चिकाली च संहेतः । एण्डुकाधितं कोष्णं विवेद्वत्क्वाणहम् ॥ २०१॥

विवेदन्तपानं च त्रिवृत्तमूलपूतं जलम् ॥ २०२॥

यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलद्वयस्य च ॥ १०३॥

क्वाथे दधिपयश्वाश्चर्वचित्रकनागैः । पिप्पलीभिश्च तिस्रदं सर्पिज्वरं विवेद ॥ १०४॥

वातरसैषविबन्धं ग्रहणीदीपनं पयः । रयामालिलचकसिद्धेन सर्पिषा च विरेचयेत् ॥ १०५॥ (का० सं० खि० ११)

bhāṅgī, varambka, root of eranda, rāsāṇā and vṛścikāṭī should be taken. This cures fever due to *vāta*. After use of this decoction water medicated with root of *bliva* should be used.

iii) Use of *ghṛta* medicated with decoction of *yava, kola, kulathā* and both the *pañcamūlās* along with curd, *yavakṣāra, cavya, cīraka, māṅgāra* and *pīppalī* cures fever and constipation caused by *vāta* with *śleṣmā* and also cures *grahmī*, besides it is appetizer. Use of this *ghṛta* should be followed by purgation given with *ghṛta* medicated with *śvāṇā* and *tilvaka*.

(अ ५) पयः (Congenial diet)

उचित काल में भोजन के साथ पञ्चमुष्टिक यूप, अम्ल (काञ्ची), लवण तथा जाङ्गल मांसस का प्रयोग करना चाहिए।
At appropriate period soup of *pañcamuṣṭika, kāñjī*, salt and meat soup of wild animals should be used along with diet.

अ) सूतिका के पित्तचर को चिकित्सा (*Treatment of puerperal fever due to pitta*)

आ१) सामान्य चिकित्सा-सिद्धान्त एवं पयः (Principles of treatment and congenial diet)

उष्णो वर्णश्च पवनः पिते वोष्णं विरुद्ध्यते। अतीक्ष्णोपद्रवं तस्मात् पित्तचरमुपक्रमते ॥११०॥

कषायतिक्तमधूः प्रदेहप्यञ्जनौषधैः ॥१११॥

अन्तानि चान्पानानि तथोष्णकटुकानि च। पित्तचरे विरुद्धानि प्रयत्नीकानि चाचेत् ॥११२॥

(का० सं० खि० ११)

उष्णता (उष्ण द्रव्य प्रयोग) पित्त विरोधी है अतः उष्ण वायु (सेवन) (पित्तचर में) वर्जित है। जिसमें तीक्ष्ण उपद्रव नहीं है ऐसे पित्तचर में कषाय, तिक्त एवं मधुर औषधियों से प्रदेह तथा अप्यञ्ज द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए।

पित्तचर में अम्ल, उष्ण तथा कटु अन्न-पान का परित्याग तथा इनके विपरीत गुण वाले (मधुर, तिक्त, कषाय रस वाले शीत) पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए।

Heat or hot things are harmful in *pitta* disorders, hence use of hot air is contra-indicated. Fever due to *pitta* not associated with complications should be treated with unctions or massage with *kaṣāya, tikta* and *madhura* drugs.

In fever due to *pitta*, the *amla* (sour), *uṣṇa* (hot) and *kaiu* (bitter) things should not be used in eatables or drinkables. The things of opposite character i.e. *madhura* (sweet) *tikta* (purgent), *kaṣāya* (astiringent) and *śīta* (cold) should be used.

(आ २) बाह्य औषधि-प्रयोग (Medicines for external application)

- १) शरीर पर दारु, लालीस (पत्र), उशीर तथा चन्दन का प्रदेह करना चाहिए^१।
- २) मधुक तथा तार के कल्क से सिद्ध तैल का अप्यञ्ज चर का नाश करता है^२।
- i) Uction over body of pestled *dāru*, leaves of *lālisa*, *uśira* and *candana* should be given.

given.

१. पञ्चमुष्टिकयुष्ण युक्तान्तरावणेन च ॥१०२॥

मुञ्जीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन वा ॥१०३॥ (का० सं० खि० ११)

२. प्रदेहेदारुसंयुक्तेलालीसोशीरचन्दनैः ॥१२२॥

मधुकस्य च कल्केन कल्केन तारास्य च। तैलमप्यञ्जनं सिद्धं पीतं ज्वरमपोहति ॥१२३॥ (का० सं० खि० ११)

ii) Massage of oil prepared with paste of *madhuka* and *lagura* relieves fever.

(आ ३) आभ्यन्तर औषधि-प्रयोग (Oral medicines)

१) शाङ्खि, मरुवा, पाठा, नक्तमाल, वत्सक, निम्ब, आरावध तथा उशीर का आसव बनाकर मधु के साथ पीना चाहिए^१।

२) स्थिरादयः पञ्चमूल, केशर, कशेरक, गोपी, पर्पटक, उशीर तथा धान्यक को मिलाकर सिद्ध कर (क्वाथ बनाकर) चतुर्धारा शेष रहने पर शीतल करके मधु एवं शर्करा के साथ पीना चाहिए^२।

३) मुस्त, दोनों सांरिवा, उशीर, यष्टिका, लोष, पत्रक तथा ससर्पण आदि आठ द्रव्यों को आधे आठक पानी में भिगोकर रात्रि पर्यन्त रखने के बाद छानकर शर्करा तथा बारीक पिसी हुई कटुरोहिणी को एक कर्ष की मात्रा में मिलाकर पिलाना चाहिए। यह अभिषेक राज सभी ज्वरों का निवारण करता है^३।

४) मुष्टिका, नागपुष्प, मरिच, शर्करा, पत्र, एला तथा चव्य का पानक वैतकचर में देना चाहिए^४।

५) भद्रश्री, तिन्दुक, मुस्ता, पयस्या, मधुक तथा चवा के कषाय का पान ज्वरतिरसा-नाशक है^५।

६) पुरिषनर्णी तथा स्थिरा से युक्त मुद्गा-यूष पीने को देना चाहिए (यह भी ज्वरतिरसा-नाशक है)^६।

७) सांरिवा, चन्दन, उशीर, द्राक्षा तथा पत्रक से सिद्ध की हुई लाजा से बनी पेया वमन, मूर्छा, दाह तथा ज्वर-का नाश करती है। इस (लाज-पेया) को मुद्गा-यूष अथवा मधुर-रस के द्रव्यों के साथ पीना चाहिए^७।

८) मधुक, केशर, गोपी, निम्बपत्र, कशेर तथा शर्करा एवं मधु मिलाकर बनाया हुआ लोह मुख-शोधन करता है^८।

९) मधुक एवं तार के कल्क से सिद्ध तैल का पान ज्वर का नाश करता है^९।

१०) पटोल, गुडूची, रोहिणी, आरावध तथा चन्दन के कल्क से सिद्ध घृत ज्वर का नाश करता है^{१०}।

११) चन्दनादि अथवा पटोलादि वर्ग की औषधियों से सिद्ध घृत अथवा तिक्तसर्पिं या तिक्तिराघ घृत का प्रयोग करना चाहिए^{११}।

i) The *āsava* prepared with *śārngiṣhā, māruvā, pāṭhā, natamāla, vatsaka, nimba, āragavadhā* and *uśira* should be given with honey.

ii) *Shhāṇḍya pañcamūla, keśara, kaśēruka, gopī, parpatāka, uśira* and *dhānyaka* all in

१. शाङ्खिं मरुवं पाठं नक्तमलं सवत्सकम् ॥१११॥

निम्बमागवधोशीरमसुतं मधुनां पिबेत्। स्थिराद्यं पञ्चमूलं च केशरं सवत्सकम् ॥११२॥

गोपीं पर्पटकोशीरं धान्यकं चेति साधयेत्। पाठावशिष्टं तच्छीतं पिबेत् समयुष्कम् ॥११३॥

मुस्तद्रिस्तारिषोरीयाष्टिकालोषपत्रकैः। ससर्पणैर्याङ्गैर्वर्धकैर्कामासुतम् ॥११४॥

तंत्रिणामुषितं घृतं पातव्यं शर्करायुतम्। कर्षेण कटुरोहिण्याः श्लक्ष्णोपदेन चाचितम् ॥११५॥

सर्वभिषेकराजोऽयं सर्वज्वरनिवारणः। मुष्टिकानागपुष्पं च मरिचान्यथ शर्करा ॥११६॥

पत्रमेला च चव्यं च पानकं वैतकिके ज्वरे। भद्रश्रीतिन्दुकोमुस्ता पयस्या मधुकं वत्सा ॥११७॥

कषाय एषां पालव्यो ज्वरतीसारनाशनः। पिबेन्मुदरसं वाऽपि पुरिषनर्णीस्थिरायुतम् ॥११८॥

सांरिवाचन्दनोरीद्राक्षापत्रकसाधितम्। लाजपेयां पिबेच्छीतमूर्च्छादाहज्वरपहादम् ॥११९॥

मुद्गपुष्पेण वाऽशनीयामधुरेण रसने वा। मधुकं केशरं गोपीं निम्बपत्रकशेरकम् ॥१२०॥

शर्करामधुसंयुक्तो लोहो मुखविशोधनः ॥१२१॥

मधुकस्य च कल्केन कल्केन तारास्य च। तैलमप्यञ्जनं सिद्धं पीतं ज्वरमपोहति ॥१२३॥

पटोलस्य गुडूच्याश्च रोहिण्यारावधस्य च। चन्दनस्य च कल्केन सिद्धं सर्पिर्वर्जपहम् ॥१२४॥

चन्दनाद्येन वा सिद्धं पटोलाद्येन वा घृतम्। पायोक्तिसर्पिर्वा तिक्तिराघयणीषि वा ॥१२५॥ (का० सं० खि० ११)

equal quantity should be boiled (with sixteen times water), when one fourth remains it should be (strained) cooled and be given with honey and sugar.

iii) *Mustā*, both the *sārivās*, *uśīra*, *yashtikā*, *lodhira*, *padmaka*, and *saptaparnā* etc. eight drugs should be kept overnight with half *ādhaka* water. In next morning after straining properly, it should be mixed with sugar and finely powdered or pestled *kajurohinī* in the amount of one *karṣa* and given for drinking. This *abhiśovarājā* (king of beverages) cures all types of fevers.

iv) Use of cold percolation of *mṛdvīkā*, *nāgaphuṣpa*, *marica*, *sugara*, *patra*, *elā* and *cavya* is beneficial in *paitika* fever.

v) Use of decoction of *bhadraśīr*, *tinduka*, *mustā*, *payasā*, *madhuka* and *vacā* cures fever associated with diarrhoea.

vi) Soup of *mudga* (a kind of bean) mixed with *prāṇiparnā* and *sthīrā* cures fever associated with diarrhoea.

vii) The beverage prepared with *lājā* (parched paddy) medicated with *sārivā*, *candana*, *uśīra*, *drākṣā* and *padmaka* cures vomiting, unconsciousness, burning sensation and fever. This beverage should be taken either with soup of *mudga* or decoction of the drugs of *madhura* group.

viii) An electuary prepared with *madhuka*, *keśara*, *gopī*, leaves of *nimba*, *kaśēra*, *sugara* and honey cleanses the mouth.

ix) Drinking of oil medicated with paste of *madhuka* and *tagara* cures fever.

x) Use of *ghṛta* medicated with paste of *paṭola*, *guḍūcī*, *rohinī*, *āragvadhā* and *candana* cures fever.

xi) *Ghṛta* either prepared with *candana* group or *paṭolādī* group of drugs or else *ritā-sarpī* or *ittirādyā ghṛta* should be used.

(आ ४) पित्तचर का वेग शान्त होने पर चिकित्सा (Treatment after remission of fever due to pitta)

शान्तवेगे चरे चास्यै दद्यान्मृद्विरेचनम् ॥ १२१ ॥

चतुर्दशमृद्विकाविवृत्कल्केन बुद्धिमान् । प्रतिहेदारुसंयुक्तैस्तालीसोशीरचन्दनैः ॥ १२२ ॥

(का० सं० खि० ११)

चर का वेग शान्त हो जाने पर बुद्धिमान् (वैद्य) को चतुर्दश, मृद्वीका तथा त्रिवृत्-कल्क से मृदु विरेचन तथा देवदारु, तालीसपत्र, उशीर एवं चन्दन का प्रदेह करना चाहिए ।

After remission of fever, the wise physician should prescribe purgation with paste of *caturāṅgula*, *mṛdvīkā*, and *trivṛt* and unction with paste of *devadāru*, leaves of *tālāsa*, *uśīra* and *candana*.

इ) सूतिका के रजोमचर की चिकित्सा (Treatment of fever due to śleṣmā of a puerperal woman)

(इ १) चिकित्सा-सिद्धान्त एवं पथ्य (Principles of treatment and congenial diet)

सम्यक्संसाधेन भान्तवेगं कफचरम् । जयेद्देहव्यपन्नैश्च सर्षिषाभ्यञ्जनेन च ॥ १२७ ॥

नागाभामदारभ्यां श्रुतमुष्णं पिबेज्जलम् । बालमूलकमृषेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ १३१ ॥
कटूष्णद्रव्ययुक्तेन मन्दस्निग्धेन भोजयेत् ॥ १३२ ॥

शेषं बालचरहितं कार्यमथ चिकित्सितम् । मधुराण्यन्नपानानि स्निग्धानि च गुरुणि च ॥ १३८ ॥
कफचरे विवर्ज्यानि प्रयत्नीकानि चाचरेत् ॥ १३९ ॥ (का० सं० खि० ११)

भली भाँति प्रयुक्त संसर्जन क्रम से (पेशादि के प्रयोग द्वारा) कफचर का वेग भग्न हो जाने पर अर्थात् कम हो जाने पर उसे औषधि-पान तथा घृत एवं अभ्यङ्ग द्वारा ठीक करना चाहिए ।

नागर एवं अमरदारु से फकाया हुआ उष्ण जल पीने को देना चाहिए ।

बाल-मूलक का यूँ अथवा जाङ्गल-मांसस को कटु एवं उष्ण द्रव्य तथा थोड़ा स्नेह डालकर भोजन के लिए देना चाहिए । बालचर में हितकारी चिकित्सा यहाँ भी करनी चाहिए ।

मधुर, स्निग्ध तथा गुरु अन्नपान का कफचर में पीलियाग करना चाहिए तथा इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए ।

After remission of fever due to *kapha* by use of diet in *samsarjana-krama* (regulated diet) it should be managed by use of beverages of medicines, *ghṛtas* and *massage*.

Hot water cooked with *radga* and *amaradāru* should be given for drinking.

Soup prepared with young radish or meal of wild animals mixed with bitter and hot substances/drugs and little quantity of fat should be given in diet. Treatment prescribed for fever due to *vāta* is also beneficial.

In fever due to *kapha* use of *madhura* (sweet), *snigdhā* (unctuous) and *guru* (heavy) diet and drinkables is contraindicated, the things of opposite character to these sweet etc. should be used.

(इ २) बाह्य औषधि-प्रयोग (Medicines for external application)

(१) लाक्षा, मुस्ता, दोनों हरिद्रा, शलाह्ला, भद्रोहिणी, देवपुष्पा, वचा, दारु तथा सरल को समान भाग लेकर इनसे तैल पाक करके, उससे वैद्य अभ्यङ्ग कराने ।

(२) कुष्ठ, अगर, व्याघ्रनख, माँसी, धान्यक, सामक (कोई द्रव्य नहीं है अतः शु० पाठ रामठ), वक्र, हरेणु, हीबेर, रसौण्य, केसर, त्वचा, एलाड्य, सरल, दारु, मूर्वा, कालानुसारिवा, बाहिष्ठ, शलपुष्पा, पुष्पीका तथा देवपुष्पक को समान भाग लेकर बुद्धिमान् (वैद्य) तैल का पाक करे । उसके मर्दन मात्र से ही कफचर नष्ट हो जाता है ।

i) The physician should prescribe massage of oil prepared with equal quantity of *lākṣā*, *mustā*, both *haridrās*, *śālāhwa*, *bhadrarohini*, *devapūṣpā*, *vacā*, *dāru* and *sarala*.

ii) Wise physician should prepare oil with equal quantity of *kusṭha*, *agara*,

१. लाक्षा मुस्ता हरिद्रिह शलाह्ला भद्रोहिणी ॥ १३३ ॥

देवपुष्पा वचा दारु सरलं चेति तैः समैः । पचेत्तैलं तत्तेन कुर्यादभ्यञ्जनं पिषक् ॥ १३४ ॥

कुष्ठपुष्पाव्याघ्रनखं माँसी धान्यकसामकम् (रामठ-शु० पा०) ।

वक्रं हरेणुं हीबेरं रसौण्यं केसरं त्वचम् ॥ १३५ ॥

एते हे सरलं दारु मूर्वा कालानुसारिवा । बाहिष्ठं (बाहिष्ठ-शु० पा०) शलपुष्पा च पुष्पीका देवपुष्पकम् ॥ १३६ ॥

एतैर्है समभागीरु तैलं धीरो विपचयेत् । एतदभ्यञ्जनेन कफचरसमोहति ॥ १३७ ॥ (का० सं० खि० ११)

vāghravanakha, māṃsī, dhānyaka, rāmāṭha, vakra, hareṇu, hībera, shāunṭeya, kesara, mwacā, both the elās, sarala, dāru, mārva, kāānusāriva, barhiṣṭha, śatvapuspā, prāthivikā and devapuspaka. Massage with this oil cures fever due to kapha.

(इ ३) आयुर्वेद औषधि प्रयोग (Oral medicines)

(१) प्रारम्भ में दोनो बड़ती, पुष्कसूत, दारु, पिप्पली, नागर तथा शटी के उष्ण क्वाथ का पान दोषों का पाचन करता है।

(२) दोनो पञ्चमूल, भाङ्गी, कर्कटा, दुलालभा, नागर, पिप्पली तथा दारु को (के क्वाथ को) सैश्व मिलाकर पीने को देना चाहिए।

(३) पटोल, धान्यक, मुस्ता, मूवा, पाठा, निदिघका इन छहों द्रव्यों को समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर मधु के साथ पीने को देना चाहिए।

(४) विरेचनार्थ त्रिवृत्-कल्क को गोमूत्र के साथ देना चाहिए।

(५) उचित काल में कल्याणक अथवा दाशमौलिक (दशमूल से सिद्ध) घृत का सेवन करना चाहिए।
i) Initially use of hot decoction prepared with both bṛhātis, puṣkaramūla, dāru, pīppalī, māgara and śaṭ metaboliases doṣas.

ii) Decoction of both pāñcamūla, bhāṅgī, karkāṭa, durālabha, māgara, pīppalī and dāru mixed with rock salt should be prescribed.

iii) Decoction prepared with equal quantity of six drugs i.e. paṭola, dhānyaka, mustā, mārva, pāṭha, and nidighikā mixed with honey should be given.

iv) For purgation paste of trivṛt with cow urine should be prescribed.

v) Kalyāṇaka or daśamūla ghṛta should be used in suitable and appropriate period.

ई) सूतिका के सात्रिपातिक चक्र की चिकित्सा (Treatment of fever due to sannipāta or all the three doṣas together of puerperal woman)

सन्निपातचक्ररसातः प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम् ॥ (का० सं० छि० ११/१३१)

अब मैं सान्निपातिक चक्र की चिकित्सा कहूँगा।

Now I shall describe the treatment of fever due to sannipāta.

(इ १) साध्यासाध्यात (Prognosis)

स सर्वलक्षणोऽसद्यः कृच्छ्रसाध्याऽत्यन्तक्षयः। बलहीनस्य नष्टाग्नेः सर्वथा नैव सिद्ध्यति ॥ १४०॥
स सर्वलक्षणानां तु क्षीणघातुलौजसम्। तथापि यत्नमातिशेदानुशंस्याद्विषयवतः ॥ १४१॥
किमङ्गः। सूतिकाणां तु क्षीणघातुलौजसम्। (का० सं० छि० ११)

१. बृहत्सौ पुष्करं दारु पिप्पली नागरं शटी। क्वाथमेव विवेदुष्णमादौ दोषविपाचनम् ॥ १२८॥
द्विपञ्चमूर्ती भाङ्गी च कर्कटायां दुलालाम्। नागरं पिप्पलीं दारुं विवेदा सैश्ववाचितम् ॥ १२९॥
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूवा पाठा निदिघका। कषाय एषां पातव्यः षडङ्गो मधुसंयुतः ॥ १३०॥
विवेदोऽप्यनुक्तं त्रिवृत्कल्काविरेचनम् ॥ १३१॥

कारो कल्याणकं सर्पिः विवेदा दाशमौलिकम् ॥ १३३॥ (का० सं० छि० ११)

सर्व लक्षण-युक्त सान्निपातिक चक्र असाम्य तथा अल्प लक्षण-युक्त कष्टसाम्य होता है। बलहीन एवं नष्टाग्नि सूतिका में भी यह सर्वथा असाम्य होता है। उस सूतिका का क्या कहना जिसकी धातुयें, बल एवं ओज क्षीण हो गया हो अर्थात् उसका सात्रिपातिक चक्र ठीक नहीं हो पाता, फिर भी श्रेष्ठ चिकित्सक को दया पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए।

Fever due to sannipāta having manifestation of all the clinical features is incurable, while with few signs and symptoms is cured with difficulty. In the puerperal woman having lost her bala (strength) and agni (digestive or metabolic capacity) also this fever never gets cured. What to say about the puerperal woman whose dhātus, bala (strength) and ojas have decreased or in other words sannipātika fever of such woman also does not get cured, however, good physician should make proper efforts with compassion.

ई २) सात्रिपातिक चक्र के चिकित्सा-मिद्धान्त (Principles of treatment of fever due to sannipāta)

सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान् भवेत्।

तमेवादौ प्रथमयेच्छेदोषमतः (दोषावतः-शु० पा०) परम् ॥ १४२॥

अत्यन्तबलेषु दोषेषु (पतिमान् भिषक्। श्लेष्माणमादौ शमयेत् स हेषामनुबन्धकृत् ॥ १४३॥

गुलत्वात् कृच्छ्रपाकिन्त्वादूर्ध्वकायाश्रयात्तथा।

तस्माज्ज्वरेण दुर्दिष्टं (तस्माज्ज्वरे तु निर्दिष्टं-शु० पा०) वातपित्तकफान्तके ॥ १४४॥

तस्यां तस्यामवस्थायां ततश्च कार्यं चिकित्सितम्। सामान्येन तु वक्ष्यामि तद्विशेषं भिषग्विज्ज्ञतम् ॥ १४५॥

शीतोष्णौषधैस्तैलं सर्वैरौषासंस्कृतम् ॥ १४७॥

अभ्यङ्गनं विधातव्यं यच्चान्यन्तिमत्पादम् ॥ १५८॥ (का० सं० छि० ११)

सन्निपात के दोषों में जो दोष सबसे अधिक बलवान् हो सर्वप्रथम उसका प्रथमन करना चाहिए, अन्य दोषों की चिकित्सा बाद में करनी चाहिए। बुद्धिमान वैद्य को चक्र के अल्पातन्त्र (यदि दोषों के प्राबल्य में विशेष अन्तर न हो सभी लगभग एक मात्रा में हो प्रकृति होने पर) वाले दोषों में सर्वप्रथम श्लेष्मा का शमन करना चाहिए क्योंकि यह अनुबन्धकारक, गुरु, कृच्छ्रपाकी तथा ऊर्ध्वकाय में आश्रित होता है। तत्पश्चात् उस स्त्री के सान्निपातिक चक्र की वातपित्तकफान्तक चक्र में निर्दिष्ट चिकित्सा, अवस्था (चक्र में दोष प्राधान्य की अवस्था) के अनुसार सामान्य रूप में करनी चाहिए। विशिष्ट चिकित्सा का अब मैं वर्णन करूँगा।

सम्पूर्ण शरीर का उष्ण एवं शीत औषधियों से संस्कृत तैल से अभ्यङ्ग करना चाहिए तथा अन्य सभी विदोष को नाश करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए।

Amongst all the three doṣas of sannipāta most predominant doṣa should be pacified first and other doṣas should be treated afterwards. In a case where all the doṣas are vitiated almost in identical strength, the wise physician should first of all pacify kapha, because it involves or attaches other doṣas, is guru (heavy), gets metabolised with great difficulty and is situated in upper part of the body. After pacifying this kapha she should be treated giving due consideration to the stage of fever on the general lines of fevers due to vāta, pitta, kapha etc. Now I will describe specific treatment.

Whole body should be massaged with oil medicated with hot or cold drugs and other measures capable of suppressing tridoṣa should be used.

(ई ३) बाह्य औषधि-प्रयोग (Medicines for external application)

(१) कुश, काश, श्वदंष्ट्रा, अर्क, सुषा, एण्ड, परुषक तथा अन्न (शालि ?) एवं यव एक द्रोण मात्रा में लेकर (पका कर कुश का रूप में) चमड़े में युक्तिपूर्वक फैलाकर (उसी चमड़े में फैली कुश का ऊपर लेटी) सूतिका स्त्री को भारी कपड़ों से आच्छादित करके स्वेदन करें^१।

(२) हरीतकी, त्रियङ्गु, मालती एवं आमलकी से अथवा वासा या खदिर से मुख का प्रच्छालन करना चाहिए^१।

(३) खल्ल्या पिष्ट आम्रस्थि तथा रसाञ्जन को मिलाकर दन्तमार्स, ओष्ठ तथा जिह्वा का प्रतिसारण करना चाहिए^१।

(४) शिर में अत्यधिक संतप (तीव्र ज्वर एवं शिरःशूल) होने पर दीर्घ, सर्जरस, अक्षत (ज्व) एवं अश्वगंधा (कल्क) को मधु के साथ मिलाकर ललाट पर उपलेहन (आलेपन) करना चाहिए^१।

i) *Kuśa, kāsā, śwadamāṣṭrā, arka, suhītā, eravāla, parāṣaka, cereals (śālī rice) and yawa* (barley) (all in equal quantity) should be taken in the amount of one *droṇa*, cooked in the form of oleo, spreaded properly over a sheet of leather and sudation with this should be given to the woman (lying over this oleo) after covering her with heavy cloth.

ii) Oral cavity should be washed with either *haritakī, prīyaṅgu, mālatī and āmalakī* or *vāsā* or *khadira*.

iii) Gums, lips and tongue should be rubbed with finely powdered stone of mango fruit mixed with *rasājñāna*.

iv) In case of severe headache due to high fever paste of *sarjaraśa, yawa* and *aśwagandhā* mixed with curd and honey should be applied over forehead.

(ई ४) आभ्यन्तर औषधि प्रयोग (Oral medicines)

(१) नागर, दशमूल, कट्वङ्ग, दारुकद्वय, पिप्पली, त्रिफला, भार्गो, कर्कटक तथा दुरालभा के क्वाथ को पूर्वान्न एवं अपरान्न में होने वाले ज्वर में सैषव के साथ तथा सायंकाल होने वाले ज्वर में मधु तथा हिङ्गु के साथ मिलाकर देना चाहिए^१।

(२) पटोल, मुस्ता, मधुक, रोहिणी आदि (द्रव्यों के क्वाथ को) को वातप्रधान सान्निपातिक ज्वर में घृत के साथ पिलाना चाहिए^१।

(३) कफप्रधान सान्निपातिक ज्वर में इन्हीं (पटोल, मुस्ता, मधुक एवं रोहिणी) औषधियों को त्रिफला एवं सुरदार के साथ मधु मिलाकर पीने को देना चाहिए^१।

(४) सान्निपातिक ज्वर में पित्त की अधिकता होने पर ऐला, मधुक, मधुक, शीतपाकी, परुषक, त्रिफला, सांनिवा, पाठा, मज्जिष्ठा तथा चतुर्द्वल (के क्वाथ) में मधु एवं शर्करा डालकर पीना चाहिए^१।

१. कुशकाशश्वदंशर्कसुषैरण्डपरु(र्कः) । त्रयवद्रोणं चर्मण्यास्तीर्णं युक्तितः ॥ १४६ ॥

स्वेदयेत् सूतिकां तत्र गुग्गुलुवरणावृताम् ॥ १४७ ॥

हरीतक्या त्रियङ्गवा च मालत्याऽम्ब (लेकेन) च ॥ १५८ ॥

मु(ख) प्रक्षालनं कर्तव्यं वासाया खदिरिण वा । शल्ल्यापिष्टं तथाऽम्रास्थि रसाञ्जनसमन्वितम् ॥ १५९ ॥

दन्तान्सिद्धिजिह्वानां प्रधानं प्रतिसारणम् । सन्तप्यमाने शिरसि दीर्घसर्जसाक्षरैः ॥ १६० ॥

साक्षराश्चैर्मधुयुतैर्ललाटमुपलेहयेत् ॥ १६१ ॥ (का० सं० वि० ११)

नोट - आम्रालत औषधि के सन्दर्भ पृष्ठ ६०५ में देखें।

(५) भार्गो, शृङ्गी, त्रिवृत्, दन्ती, दशमूल, दुरालभा, कट्वङ्ग, त्रिफला, शुण्ठी तथा पिप्पली से बनाए हुए क्वाथ में सैषव तथा क्षार मिलाकर अनुलोमन (दोषों के) के लिए पान कराए अथवा गोमूत्र में मिलाकर त्रिवृत् या केवल वचा का पान करें। दोषों के अनुलोमन तथा ग्रहणी के बलवान (अग्नि के दोष) हो जाने पर भलीभाँति संस्कृत घृत का पान कराना चाहिए^१।

(६) मधुक, अतिविषा, रोहिणी तथा भद्रदार से सिद्ध घृत अथवा कल्याणक या महाकल्याणक या पञ्चागव्य घृत का उचित काल में प्रयोग सान्निपातिक ज्वर का नाश करता है^१।

(७) ज्वर के आठ दिन बीते जाने के बाद लघु अन्न को संसर्ग क्रम से प्रयोग करने के पश्चात् द्रव्य या सान्निपातिक ज्वर में वायु की प्रधानता के कारण प्रत्याप होने, विशेष कर शूल के साथ मल-मूत्र का विवर्ण तथा श्वासकष्ट होने पर पुराने घृत से संस्कृत जाड़ल मांसस देना चाहिए। दशमूल, कुलथ, यव, कुल्ल, कुलीशृङ्गी, रातना, शटी, पुष्करमूल, भार्गो तथा दुरालभा के भलीभाँति सिद्ध निर्वृह के प्रयोग से रोगी का विगुणित हुआ वायु तथा ज्वर शान्त होता है^१।

(८) पाचन द्रव्यों के प्रयोग से ज्वर का वेग शान्त होने, परन्तु पक्ववाशेष मल रहने तथा बल (दोषों के बल) के कम हो जाने पर इन दो संशयन द्रव्यों का शीतल क्वाथ पशु के साथ प्रयोग करना चाहिए-पिप्पली तथा दुरालभा अथवा मुद्गीका तथा पिप्पली^१।

(९) गुड़ची एवं आमलक के स्वरस तथा सारिवा, शुण्ठी, लोध, दाडिम एवं चन्दन के कल्क से सिद्ध किए घृत का नाम मङ्गल्यक घृत है यह विषमज्वर-नाशक तथा सभी ज्वरों में अमृत के समान लाभदायक है^१।

i) Decoction of *nāgara, dāsamūla, kawāṅga, dārūkadhwyā, pipplā, triphalā, bhāṅgū, karakāṭaka* and *durālābhā* should be given with rock salt in the fever rising in morning and

१. नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दारुकद्वयम् ॥ १४७ ॥

पिप्पल्यस्त्रिफलाभार्गो कर्कटावृषा दुरालभा । ससैचवः कषायोऽयं ज्वरे पूर्वापराह्निके ॥ १४८ ॥

मधुहिङ्गुसमायुक्तो देयः सायान्दिके ज्वरे । पटोलमुस्तामधुकोरुहि ॥ १४९ ॥

सर्पिणा सह पातव्यं सन्निपातेऽनिलोत्तरे । एतदेव त्रिफलाया युक्तं च सुरदारण्या ॥ १५० ॥

पायवेन्मधुनाऽलोड्य सन्निपाते कफोत्तरे । एतामधूकमधुकशोलापानीरुचकैः ॥ १५१ ॥

त्रिफला सारिवा पाठा मज्जिष्ठाचतुर्द्वलैः । पित्तोत्तरे त्वभि(न्यासे)पिबेत्, समधुशर्कराम् ॥ १५२ ॥

भार्गो शृङ्गी त्रिवृदन्ती दशमूली दुरालभा । कट्वङ्गं त्रिफला शुण्ठी पिप्पली चैतैः शृतम् ॥ १५३ ॥

क्वाथं ससैचवक्षारं पायवेच्चानुलोमिकम् । गोमूत्रयुक्तं त्रिवृत् केवलं वा चचा पिबेत् ॥ १५४ ॥

अनुलोमं गते दोषे सञ्जाते ग्रहणीवले । ततः सर्पिर्वा साधु संस्कृतम् ॥ १५५ ॥

मधुकेनातिविषया रोहिण्या भद्रदारण्या । सिद्धं सर्पिः पिबेत् काले सन्निपातज्वराग्रहम् ॥ १५६ ॥

कल्याणकं महान्तं वा पञ्चागव्यमपि वा ॥ १५७ ॥

लघ्वन्नकृतसंसर्गं निरय्याहरे ज्वरे ॥ १५८ ॥

संसर्गं सन्निपाते वा सप्रलापेऽनिलोत्तरे । सशूलवृद्धविण्मूत्रे सक्षप्ते च विशेषतः ॥ १५९ ॥

पुराणसर्पिः संस्कारो विधेयो जाङ्गलो रसः । दशमूलकुलथानां यवानां कुवलस्य च ॥ १६० ॥

कुलीशृङ्गीया रातनायाः शटीपुष्करमूलयोः । भार्या दुरालभायाश्च निर्वृद्धे साधु साधितः ॥ १६१ ॥

तेनास्य विण्मूत्रे वायुज्वरक्षारस्य प्रशाम्यति । पाचनीयैरुपक्रान्ते मग्नयो सति ज्वरे ॥ १६२ ॥

पक्ववाशेषे च मले बले मन्दत्वभाते । पेयं सुशीतं सक्षार्द्रमिदं संशयनद्वयम् ॥ १६३ ॥

पिप्पली सुरदारण्या मुद्गीका वा सपिप्पली । गुडच्यानलकानां च स्वसे सधिर्वा शृतम् ॥ १६४ ॥

कल्केन सारिवाशुण्ठी लोधदाडिमचन्दनैः । तदिह मङ्गल्यकं नाम विषमज्वरनाशनम् ॥ १६५ ॥

ज्वराणां चापि सर्वेषामेतेनानुलोमम् ॥ १६६ ॥ (का० सं० वि० ११)

evening both the times and in the fever rising only in the evening with honey and *hingru*.

ii) Decoction of *patola*, *mustā*, *madhuka*, *rohiṇī* etc. mixed with *ghrita* should be prescribed in fever due to *sannipāta* having predominance of *vāta*.

iii) In fever due to *sannipāta* having predominance of *kapha*, decoction of *patola*, *mustā*, *madhuka*, *rohiṇī*, *triphalā* and *suradāru* mixed with honey should be given.

iv) In fever due to *sannipāta* having predominance of *pitta*, decoction of *elā*, *madhūka*, *madhuka*, *śītapāki*, *pariśada*, *triphalā*, *sarivā*, *pāṭhā*, *maṅgiṣṭhā* and *caturāṅgulā* mixed with honey and sugar should be given.

v) For *anulomana* of *dosas* (movement of *dosas* in their normal channels) either decoction of *bhāraṅgī*, *śrīṅgī*, *trivṛt*, *danī*, *daśamūla*, *durālābhā*, *kaiṣoreṅga*, *triphalā*, *śunthī* and *pippalī* mixed with rock salt and *yauvekṣāra* or *trivṛt* mixed with cow urine or only *vaca* (decoction) should be given. Once *dosas* have started moving in their proper channels and *grahaṇī* (digestive capacity or appetite) has become strong, then properly prepared *ghrita* should be given for drinking.

vi) Use of either *ghrita* prepared with *madhuka*, *ativīṛ*, *rohiṇī* and *bhadradāru*, or *kalyāṇaka* or *mahākalāyāṇaka* or *pañcagavya ghrita* in appropriate and suitable period cures fever due to *sannipāta*.

vii) After lapse of eight days of fever, then use of light diet with *saṁsārjanakrama* (serial way) if in the fever caused by two *dosas* (*dwandvija*) or all the three *dosas* (*śannipātika*) delirium due to predominance of *vāyu*, specially retention of urine and constipation associated with pain and dyspnoea occur, then meal soup of wild animals mixed with old *ghrita* should be given. Afterwards use of decoction of *daśamūla*, *kulathī*, *yava*, *kuwala*, *kulīraśrīṅgī*, *rāsnā*, *śatī*, *puṣkaramūla*, *bhāraṅgī* and *durālābhā* pacifies vitiated *vāyu* and fever both.

viii) Two pacifying cooled decoctions prepared with either *pippalī* and *durālābhā* or *pippalī* and *mṛdāṅkā* should be used with honey in the cases having remission of fever due to use of digestive or metabolising drugs but retention of *mala* (feces) left over after proper metabolism and reduction in the strength of *dosas*.

ix) *Ghrita* prepared with juice of *guḍāci* and *āmāla* along with paste of *sārivā*, *śunthī*, *lodhra*, *dādima* and *canḍana* is known as *maṅgalyaka ghrita*. This cures *viśamaajwara* (intermittent fever) and is beneficial like nectar in all types of fevers.

ए) सूतिका के सन्मोक्ष एवं ग्रहोत्थ चक्र की चिकित्सा (Treatment of milk-fever and fever due to *grahas* of *puerperal woman*)—

सत्य की संशुद्धि से सन्मोक्ष चक्र (पृ० ५९०) तथा ग्रहण विधि एवं वातचक्र नाशक चिकित्सा करने से ग्रहोत्थ चक्र (पृ० ५९१) का शमन होता है।

सन्मोक्ष चक्र में लक्षणानुसार दोषप्रकोप का ज्ञान कर उस दोष के लिए वर्णित संशमन चिकित्सा करें। टीकाकार

इच्छण ने संशमन से पाचन का भी ग्रहण किया है^१।

The milk-fever is cured by expressing out the milk and fever due to *grahas* by use of measures capable of eradicating *grahas* and other treatment prescribed for fever due to *vāta*.

In milk fever, diagnosing the aggravation of *doṣa* on the basis of specific clinical features, the pacification prescribed for that *doṣa* should be used. Dalhana says that besides pacification, metabolism of *dosas* should also be done.

सामान्य प्रसवान्तराल (Normal duration of inter-pregnancy period)

एक बार प्रसव होने के कितने वर्षों के बाद स्त्री दुबारा गर्भाधान-योग्य हो जाती है इस विषय में स्पष्ट वर्णन संहिताओं में नहीं मिला। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि एक बार प्रसव से निवृत्त हो कर छह वर्षों के बाद गर्भाधान होने पर कुमार अल्पायु होता है^२। टीकाकार इच्छण ने लिखा है कि छह के अवयव अर्थात् पाँच, चार, तीन या दो वर्ष में गर्भ का पुनः जन्म सामान्य होता है, तदुपान्त प्रसव होने पर कुमार के अल्पायु होने के कारण का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि गर्भाशय या योनि आदि के दोष के कारण ही गर्भाधान नहीं होता। शोथनादि चिकित्सा, आहार-विहार-व्यवस्था तथा आकांक्षा होने पर जब (छह वर्ष की अवधि के बाद) गर्भाधान होता है तो योनि एवं गर्भाशय आदि के अस्फुटित या अस्पष्ट दोषों के कारण (यद्यपि चिकित्सा से दोष शान्त होकर गर्भाधान तो हो गया पर दोषों का पूर्ण निराकरण न हो सकने के कारण) उत्पन्न शिशु अल्पायु होता है^३।

महर्षि वाग्भट ने शरीरस्थान अध्याय ३ के समापन में केवल इतना लिखा है कि इस अध्याय में प्रथम मास से लेकर जब वह पुनः गर्भाधान योग्य हो जाती है तब तक की सम्पूर्ण विधि का वर्णन कर दिया^४। इन्होंने इस अध्याय के अन्त में सूतिकाकाल की मर्यादा वर्णन करते हुए पुरातनवदस्तीन इसकी सीमा मानी है।

जो चित्राँ स्तनपात करती रहती है, अधिकांशतः उन्हें रजःश्लेष्म प्रसव के एक वर्ष के बाद ही प्रारम्भ होता है, यद्यपि किन्हीं किन्हीं स्त्रियों को तो प्रसव के दूसरे मास से ही रजःश्लेष्म प्रारम्भ हो जाता है, अर्थात् एक प्रसव के बाद जितने दिनों में स्त्री शरीर-क्रिया-दृष्ट्या सामान्य हो जाय वह गर्भाधान-योग्य हो जाती है। अधिकतम अन्तराल की मर्यादा ६ वर्ष रखने का सम्भवतः यह कारण होगा कि इतने दिन के बाद स्त्री की श्रोणिगुहा की अस्थियाँ एवं अन्य प्रजनन अङ्ग प्रथम गर्भाधान के पूर्व सद्गुण स्थिति में पहुँच जाते हैं एवं स्त्री को प्रथम प्रसव की ही भाँति अधिक कष्ट होता है।

What should be the normal duration in between two pregnancies has not clearly been spelled in classics. Sūśruta says that after one delivery, if the woman delivers subsequently after six years then the born child is short lived. Dalhana explains that subsequent delivery should take place in five, four, three or two years, after lapse of this period the born child is short lived, because she has not conceived due to existence of certain abnormalities in uterus and other reproductive organs. After taking purifying treatment, regulated dietetics

१. सु० सं० ३०/३९/६७ (पृष्ठ ३४९)

२. निवृत्तप्रसवायासु पुनः षड्विंशो वर्षेभ्य ऊर्ध्वं प्रसवमानया नर्थाः कुमारोऽल्पायुर्भवति ॥ ६६ ॥ (सु० सं० शा० १०/६६)

३. षट्सु षड्वयवेषु पञ्चचतुर्विंशद्वर्षेसु गर्भानुजनस्य जन्मकाल इति, कुलः पुनरस्याः कुमारोऽल्पायुर्भवति ? उच्यते गर्भाशयोन्मादिदोषेण हि निवर्तते प्रसवः; तत्र तच्छोषनक्रियामन्तरेणाहारविहारदिगुणमात्रेण यदुच्छोषोपपद्यतेतर्गर्भाया योनि-गर्भाशयादिभ्यः स्फोटितलोषेषु जालोत्पन्नयुवेति ॥ (सु० सं० शा० १०/६६ की इच्छण टीका)

४. इत्याद्यं मासमादाय यावद्गर्भाशया पुनः। स्त्री स्यात्तवद्विधिः सर्वः सर्वथा साधु दर्शितः ॥ (अ० सं० शा० ३/४२)

and mode of life and also due to one's own desire though the pregnancy takes place, but due to presence of subtle abnormalities in uterus and other reproductive organs the born child is short lived.

Vāgbhata considering limit of puerperal period upto reappearance of menstruation after delivery has indirectly set this very period as the physiological gap period, because in third chapter of *Sārasthāna* he says that "I have dealt in this chapter the subject concerned with first month of pregnancy upto the period when she is capable of becoming pregnant again", he has finished the chapter after describing management of puerperium.

After delivery during lactation most women do not menstruate, though some of them do start menstruation from first month itself. Reappearance of menstruation denotes pre-pregnancy physiological status or in other words as soon as the woman reaches her pre-pregnancy physiological state, she becomes fit for subsequent pregnancy. Maximum limit of six years might have been given with the view that after such a long period, reproductive organs of the woman become just like her nulliparous state, thus subsequent deliveries become difficult just like the first labour.

प्रसवोपरान्त योनि-गाढ़ीकरण-विधि (Medicines for constriction of vagina after delivery)

फलारा (बीज) तथा उदुम्बर-फल के महीन पिसे हुए कल्क या चूर्ण को तिल-तैल के साथ मिलाकर योनि में फलीभाँति लेप करना योनि को गाढ़ी करने के लिए (स्थिबल योनि को सुदृढ़ करने के लिए) उत्तम है^१।

For constriction of lax vaginal canal, anointment with fine powder or paste of seeds of *palāśa* and fruits of *udumbara* mixed with oil of *tīla* is a good medicine.

प्रसवोपरान्त कुक्षि-ह्रस्वार्थ-औषधि (Prescription for reducing the belly after delivery)

प्रसव होने के बाद स्त्री को बढ़ी हुई कुक्षि (उदर) घटाने के लिए तीन सप्ताह तक प्रातःकाल मट्ठे के साथ कण-जटा (चूर्ण या कल्क) को मिलाकर पीना चाहिए^२।

For reducing the abdominal girth after delivery buttermilk mixed with powder or paste of *kanjāṇā* should be used.

गर्भाधानरोधक एवं गर्भसावकारक औषधियाँ या विधि (Contraceptives and abortifacients)

आधुनिक विज्ञान में परिवार-नियोजन या गर्भाधान-निरोधक विधियों का उपदेश सूतिका-परिचर्या का एवं कृत्रिम-गर्भपात परिवार-नियोजन का एक अङ्ग माना जाता है। यद्यपि इन दोनों की ही आवश्यकता विवाहोपरान्त कुछ वर्ष तक भी मानी जाती है फिर भी पूर्ण वयस्क का विवाह होने पर इनकी उपादेयता प्रसवोपरान्त ही अधिक होती है। इसी आधार पर इस विषय की सम्पत्ति प्रयुक्त ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री का संकलन किया जा रहा है।

१. (अ) फलाशुदुम्बरफलं तिलतैलसमन्वितम् । योनौ विलिप्तं मधुना गाढ़ीकरणमुत्तमम् ॥ (पा० प्र० चि० ७०/१२९)
(आ) फलाशो। योनौ प्रलिप्तं ॥ (पा० प्र० सदृश) (यो० १० स्त्रीरोगे चि०)
२. (अ) प्रसूता वसिता वृद्धकुक्षिह्रस्वाय सम्यक्वेत् । प्रातर्मीथिस्तमिश्रां त्रिसप्ताहत्कणाजटम् ॥ (पा० प्र० चि० ७०/१३०)
(आ) प्रसूता।त्रि-सप्ताहात् ॥ (पा० प्र० सदृश ही) (यो० १० स्त्रीरोगे चि०)

वृद्धवयस्की के साथ ही कारण, शाङ्गध, भेल तथा हारित आदि किन्हीं भी संहिताओं में स्पष्टरूप से गर्भाधाननिरोधक उपायों का वर्णन नहीं मिलता। गर्भाधान के लिए उपयुक्त सामग्री अर्थात् ऋतु, क्षेत्र, वीज एवं अम्रु के वर्णन से अप्रत्यक्ष संदर्भ निकाला जा सकता है कि इनमें यदि कृत्रिम रूप से परिवर्तन किया जाय तो गर्भाधान नहीं होगा। ऋतुकाल के वर्णन से ऋतुवर्ती काल को सुरक्षित काल का संदर्भ (पृ० ७२, ७६) मान सकते हैं। इसी प्रकार स्त्री की विभिन्न शारीरिक स्थितियों में मैथुन निषेध के वर्णन (पृ० ८५) से यह समझ सकते हैं कि यदि गर्भाधान की आकांक्षा न हो तो संभोग इन स्थितियों में किया जाय, क्योंकि सम्भवतः ये स्थितियाँ अपूर्ण संभोग की ओर इंगित करती हैं। गर्भपातक औषधियों के प्रयोग का उल्लेख गर्भसाव निदानान्तर्गत किया गया है^१।

बाधकाल में गर्भाधान निरोधक तथा योगरत्नाकर में गर्भाधान-निरोधक एवं गर्भपातक कुछ योगों का वर्णन है जो यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है।

Now-a-days description or advice of contraceptives is one of the integral part of postnatal management. Induction of abortion is also now considered as one of the methods to limit the family. Though need of contraceptives is sometimes felt by recently married couples, however, now-a-days when marriage of fully mature individuals take place, its necessity is felt only after delivery. Considering this point references pertaining to contraception or induction of abortion available in the books included in present work are being recapitulated here.

None of the Caraka, Suśruta, both Vāgbhata, Kāśyapa, Sātrāṅghadhara, Bhela and Hārīta etc. have mentioned contraceptives or methods of contraception in unequivocal terms. With the description of four factors i.e. *ritu* (ovulation period), *ksētra* (reproductive organs), *bija* (sperm and ovum) and *ambu* (nutrients) essential for conception, it can be indirectly inferred that if these factors are influenced artificially conception will not take place. All the methods of contraception available to-day influence one or the other factor out of these four. With the description of *rukāṇā* (fertile period) the inference for "safe period" can be drawn, similarly contraindication of various postures of woman during coitus probably hints for incomplete coitus. In the causes of abortions use of abortifacient drugs is also included.

In Bhāvaprakāśa contraceptives and in Yogaratnakara contraceptives and abortifacients have been described which are being recapitulated here.

१) गर्भाधाननिरोधक औषधियाँ (Contraceptives)

(अ) बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ (External or local contraceptives)

१) जो स्त्री सैश्व-वल्पाड को तैल में भिगोकर अपनी योनि के रन्ध्र (योनिनिर्गता) में रखकर पुरुष के साथ मैथुन करती है वह कभी भी गर्भधारण नहीं करती^१।

२) जो स्त्री ऋतु के अंत में योनिरन्ध्र का निम्बकाष्ठ से युक्तपूर्वक धुन करके मैथुन करती है उसे गर्भ स्थिर नहीं होता^२।

३) जो स्त्री कृष्णचतुर्दशी को धूरे की जड़ को उखाड़कर, कमर में धारण करके, पति के साथ मैथुन करती है

१. सु० सं० नि० ८३ एवं पा० प्र० चि० ७०/७० (पृष्ठ ३२९ से ३२३)

नोट - बाह्य प्रयुक्त औषधियों के संदर्भ पृष्ठ ६१० में देखें।

उसे गर्भ की कोई भी सम्भावना नहीं रहती, उसे खोल देने पर गर्भधारण हो जाता है, ऐसा नागार्जुन का मत है^१।

४) उपर्युक्त धरु को मूल के चूर्ण को योनि में रखने से (सम्भोग से पूर्व) गर्भ कभी भी स्थिर नहीं होता^१।

i) The woman having coitus after placing in the vaginal canal a piece of rock salt moistened with oil, never conceives.

ii) The woman who after *rukāla* properly fumigates her vaginal canal with the wood of *nimba* never conceives.

iii) There is no chance of conception to the woman having coitus after tying in the waist the root of *dhatūra* uprooted on fourteenth day of first fortnight of lunar month. Once she removes this root, she conceives.

iv) Filling of vaginal canal with the powder of above mentioned root of *dhatūra* before coitus also prevents conception.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त सभी द्रव्य प्रत्येक बार मैथुन करते समय प्रयुक्त करने चाहिए। औषधियाँ मार्गारोध करके शुक्राणु-प्रवेश-बाधक या शुक्राणु-नाशक के रूप में कार्य करती होंगी। कटि में धारण से गर्भनिरोध की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण कठिन है।

All above methods are to be used at every coitus. These might be acting as mechanical barriers and spermicidal agents. It is difficult to explain mode of action of the drug tied in the waist.

अ) आप्यन्तर प्रयुक्त औषधियाँ (Oral contraceptives)

१) जो स्त्री ऋतु के समय (ऋतुकाल में) पिप्पली, विडङ्ग एवं टंकण के समान भाग चूर्ण को दूध या जल के साथ पान करती है उसे गर्भ कदापि नहीं रहता^{१,२}।

२) जो पुष्पणी स्त्री (रजःस्राव के समय) जपाकुसुम को काझों के साथ पीसकर तीन दिन तक पीती है और एक सौ वर्ष पुराना गुड़ एक पल मात्रा में सेवन करती है वह स्त्री कभी भी गर्भधारण नहीं करती^{१,२}।

३) तण्डुलीयकमूल को चावल के धोवन के साथ पीसकर ऋतु के अन्त में (रजःस्राव के अंत में) तीन दिन तक पान, स्त्री को वन्द्या बना देता है^३।

४) तालीस और गैरिक को (समान भाग) विडालपद मात्रा में चौथे दिन (रजःस्राव के चौथे दिन) शीतल जल के साथ पीने से स्त्री वन्द्या हो जाती है^३।

१. जैतविलं सैन्धवखण्डमादौ निषाय रखा निजयोनिमध्ने ।

नेपण साधं रतिमतनोति या न सा हि गर्भं तपते कदाचित् ॥

धृषिते योनिस्थे तु निम्बकण्ठैश्च युक्तिः । ऋतुवन्ते रसते या स्त्री न सा गर्भमवाप्नुयात् ॥

ग्राह्यं कृष्णचतुर्दशं धारुस्य च मूलकम् । कटौ बद्ध्वा रमेकान्तं न गर्भः संभवेत्कदाचित् ॥

मुके न (च शु० पा०) तपते गर्भं पुरा नागार्जुनोदितम् ।

तन्मूलचूर्णं योनिस्थं न गर्भः संभवेत्कदाचित् ॥ (यो० १० योनिव्या० चि०)

नोट- आप्यन्तर प्रयुक्त औषधियों के सन्दर्भ पृष्ठ ६११ में देखें।

i) The woman who uses equal quantity of powdered *pippali*, *vidāṅga* and *tanikanya* with water or milk during *rukāla* never conceives.

ii) The menstruating woman who uses flowers of *japa* mixed with *kāñjī* followed by one hundred years old *jaggery* in the dose of one *pala* for three consecutive days never conceives.

iii) Use of root of *tanduliyuka* pestled with washings of rice for three consecutive days after menstruation makes the woman infertile.

iv) Use of equal quantity of powdered leaves of *ālīṣa* and *garika* in the dose of one *kāṣya* with cold water on fourth day of menstruation makes the woman infertile.

विमर्श (Comments)

उपर्युक्त औषधियाँ गर्भधारण का निरोध सम्भवतः निम्न प्रकार से करती हैं-

१) स्त्रीबीज को परिपक्व या उत्सर्जित होने से रोक कर।

२) गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में ही उसकी वृद्धि को रोक कर।

३) गर्भ को गर्भाशयान्तःकला में संलग्न होने से रोक कर।

४) स्त्री-प्रजननाङ्ग विशेषकर गर्भाशय-ग्रीवा के स्तम्भ में इस प्रकार के परिवर्तन कर, कि वह शुक्राणु प्रवेश न होने दे।

उपर्युक्त सभी सैद्धांतिक सम्भावनायें हैं प्रयोगात्मक परीक्षणों से ऐसा सिद्ध हुआ है कि इस प्रकार प्रयुक्त औषधियाँ अधिकांशतः गर्भ को गर्भाशयान्तःकला में संलग्न होने से रोककर परिवार-नियोजन का कार्य करती हैं।

Above mentioned preparations might be preventing conception by acting as antiovarial, antizygotic or antiimplantation agents, besides these also might be producing some such changes in the cervical mucus that it becomes hostile to sperm penetration. However, all these are hypothetical possibilities, experiments have shown that most of the drugs prevent conception by preventing implantation of fertilized egg.

२) गर्भपातक औषधियाँ (Abortifacients)

अ) स्थानिक प्रयोग (Local application)

एण्डम-काण्ड को योनि में आठ अंगुल प्रवेश करने से चार मास का गर्भ तुरन्त ही खलित हो जाता है^१।

१. पिप्पलिविडङ्गद्वयसमचूर्णं या पिबेत्तपसा । ऋतुमध्ने न हि तस्या गर्भः सञ्जायते क्वापि ॥ ३३ ॥

आरालपरिधेयं यद् न या जपाकुसुममति पुष्पणी । सत्पुण्डगुमुष्टिसेविनी सन्दधाति न हि गर्भमङ्गना ॥ ३४ ॥

(पा० १० चि० ७०)

२. पिप्पलिः.....क्वापि ॥ आरालः॥ सा दधाति ॥ (पा० १० सदृश)

तण्डुलीयकमूलानि पिष्ट्वा तण्डुलवारिणः । ऋतुवन्ते तु यद् पीत्वा वन्द्या कुर्वीत योषितः ।

तालीसैरिकेपीते विडालपदमात्रके । शीताम्बुना चतुर्थेऽहि वन्द्या नाती प्रजायते ॥ (यो० १० योनिव्या० चि०)

३. काण्डमेण्डमस्य योनावष्टाङ्गुलं क्षिपेत् । चतुर्मासोद्भवो गर्भः खलयेव हि तत्क्षणात् ॥ (यो० १० योनिव्या० चि०)

Insertion of leafstalk of *eranda* upto eight *angulas* (approximately six inches) in vaginal canal produces abortion of even four months pregnancy.

आ) आयुर्वेद प्रयोग (Oral medicines)

- १) गुञ्जन के बीज तीन टङ्क, दाडिम मूल तीन टङ्क, तुवरी २ टङ्क और सिन्दूर २ टङ्क लेकर खरल में भली भाँति पीसकर जल के साथ गर्भवती, विधवा या वेरया पान करे तो अपना गर्भ शीघ्र ही गिरा लेती है^१।
- २) चित्रकमूल को निर्गुण्डी के स्वरस में पीसकर मधु मिलाकर एक कर्ष की मात्रा में पीने से उच्चकुलोत्पन्न विधवा स्त्री अपना गर्भ गिरा लेती है^१।
- ३) गर्भवती स्त्री यदि देवालय के एक कर्ष चूने को शीतल जल के साथ पीसकर पान करे तो गर्भ शीघ्र ही स्खित हो जाता है^१।
- ४) घोट्टी के पुरीष को काझी में बोलकर कपड़े से छानकर उसमें सैन्धव, उग्र, आसुरी, तैल तथा विष मिला पान करना स्थिर गर्भ का नाश कर देता है^१।
- i) Seeds of *gryjana* three *taika*, root of *dadima* three *taika*, *unvari* two *taika* and *sindura* two *taika* properly powdered and mixed in mortar, if used with water by pregnant widow or prostitute woman produce abortion immediately.
- ii) Widow woman of high family gets herself aborted by using one *karasa* root of *citraka* pestled with juice of *nirgundi* and mixed with honey.
- iii) If pregnant woman takes lime of temple (scrappings of white washings with lime from the walls of temples) in the dose of one *karasa* mixed with cold water, she aborts quickly.
- iv) Dung of mare dissolved with *kāñjī* should be strained through cloth, in this filtrate powdered rock salt, *ugra*, *āsuri*, oil and *viṣa* should be mixed. Use of this produces abortion.



१. गुञ्जनबीजं टङ्कत्रितयं तावच्च दाडिमीमूलम् । तुवरीटङ्कद्वितयं सिन्दूरं टङ्कशुणतं च ॥
संमर्धं खल्वमध्ने तोयैर्नैतन्निपीय गर्भवती । एण्डा योधिदगर्भं वेरया वा पातयत्सायु ॥
निर्गुण्डीवसिंष्टं चित्रमूलं मधुसुतम् । कर्षं पीत्वा स्वत्सायु गर्भं एण्डा कुलोद्भवम् ॥
देवालये तु यच्चूर्णं कर्षकं तोयपेषितम् । पिबेद्गर्भवती नारी गर्भः स्ववति तत्क्षणम् ॥
अलोड्य काञ्चिकैर्घोट्टीपुरीषं वस्त्रनालितम् । ससिन्दूरशुसरी तैलविषमगतागर्भमुत् ॥ (यो० १० योनिव्या० चि०)

नवजात शिशु-परिचर्या विज्ञानीय (MANAGEMENT OF NEW BORN CHILD)

अध्याय १०
CHAPTER X

शिशु-परिचर्या के क्षेत्र में प्रसूति एवं बालरोग विशेषज्ञ दोनों का ही योगदान होता है । वर्तमान चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर यह विषय बालरोग चिकित्सकों के अधिकारक्षेत्र में माना जाता है, फिर भी प्रसव के तत्काल पश्चात् प्रसूति-विशेषज्ञ को ही नवोत्पन्न शिशु की परिचर्या का भार अधिकारतः वहन करना पड़ जाता है, साथ ही स्त्री को स्तनपान कराने आदि की शिक्षा भी देने पड़ती है; इसी आधार पर इस अध्याय में नवजात शिशु की तत्काल परिचर्या तथा स्तनपान विधि आदि का उल्लेख किया जा रहा है ।

Though now-a-days the management of new born child comes under the jurisdiction of neonatologist, however, at most of the times the obstetrician is confronted with the problem of immediate management of new born, besides advice for method of feeding etc. has also to be given. Considering this point the management of new born child, specific method of breast feeding etc. are described in this chapter.

नवजात शिशु की तत्काल परिचर्या (Care of new born immediately after birth)

तस्यास्तु खल्वपरयाः प्रपत्तायै कर्मणि क्रियमाणे जातमात्रस्यैव कुमारस्य कार्यायेतानि कर्मणि भवन्ति; तद्यथा-अश्मनोः संघट्टनं कर्णयोर्मूले, शीतोदकेनोष्णोदकेन वा मुखपरिधेकः, तथा स क्लेशविहितान् प्राणान् पुनर्लभेत । ॥ ततः प्रत्यागतप्राणं प्रकृतिभूतमभिसमीक्ष्य स्नानोदकग्रहणायुपपादयेत् ॥ ४२ ॥

अथास्य तात्त्विकपठविज्ञापमार्जनमारभेत। इत्या सुपरितुलितनखया सुप्रक्षालितोषधानकार्पासपिचुपत्त्या । प्रथमं प्रमार्जितस्यस्य चास्य शिरस्तातु कार्पासपिचुना स्नेहगर्भेण प्रतिसंछादयेत् । ततोऽस्यानन्तरं सैन्धवोपहितेन सर्पिषा कार्यं प्रच्छर्दयेत् ॥ ४३ ॥ ततः कत्पनं नाड्याः ॥ ४४ ॥

अतोऽनन्तरं जातकर्म कुमारस्य कार्यम् । तद्यथा-मधुसर्पिषो मन्त्रोपमन्त्रिते यथान्यायं प्रथमं प्राशितुं दद्यात् ॥ ४६ ॥ (च० सं० शा० ८/४२, ४३, ४४, ४६)

अथ जातस्योत्पन्नं मुखं च सैन्धवसर्पिषा विशेषाय, घृतार्कं मूर्दिष्टं पितुं दद्यात् । ततो नाभिनाडीम् छेदयेत् ॥ ॥

अथ कुमारं शीताभिर्मद्गताश्वास्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पिर्नन्तवर्णमहुल्याज्जाभिकया लेहयेत् ; ततो बलातैलेनाध्यज्य स्नापयेदनेम् ॥ (सु० सं० शा० १०/१२, १३)

तद्व्यान्यतमा स्त्री जातमात्रमेव बालं बालोपचरणोपेन विधिबोपादयेत् । तमुपदेक्ष्यते तूतरेषु ॥

अथ खलु जातमात्रमेव बालमुल्बाल सैन्धवसर्पिषा मार्जयेत् ॥ २ ॥
(अ० सं० शा० ३/३७)

ततोऽस्यातिप्रबलमोह-चरपरितसर्वाग्रस्य क्रोशितुमपिपन्नजानुरुपसमर्थस्नानवस्थिताशोदेहधातोरसम्भाव्ययौव-

नाद्यवस्थस्य कवचमशीव कवचसंशयसंसर्गं मन्थानस्याविकल्पितमङ्गानि विक्षिपतः पुनरिव मणमनुभवतो लीयमानसंभ्रमसिन्धवाधयोनिपुटप्राप्यप्रत्यानयनाय बलात्तेन परिधेकं कुर्यात् । कर्णमूले चाशमनोः संघटनम् ॥ ३ ॥

प्रत्यागतप्राणस्य च प्रकृतिभूतस्य नाभिनालं वधयेत् ॥ ५ ॥

ततः स्नापयेत् ॥ ६ ॥

ततोऽस्य सुपतिलिखितनखया सुप्रक्षालितोपवानया कार्पासपिच्यगुणिततया दक्षिणप्रदेशिन्या त्रिद्विष्टकपठमनुसुखं प्रमुन्यात् । तालु चोत्राय स्नेहपिचुनोपेष्टितदवाणुदयेत् ॥ ७ ॥

ततश्चैन्द्रीबाहीवृष्टपुष्पीवचकल्कं मधुसुतोतेतं हरेणुमात्रं कुशाग्रामिन्त्रितं सौवर्णानाश्चक्षुष्येण मेधादुर्बलजननं प्राशयेत् । तद्वत् बाहीवलानन्ताशतावर्धनमचूर्णं वा ॥ ८ ॥

ततः सैन्धवोपहितेन सर्पिषा गर्भोदकानि वामयेत् । तथःस्योरःकण्ठविषुष्या लाववमीभलाषश्च जापये ॥ ९ ॥

अथास्य जातकर्म प्राजापयेन विधिना कुर्यात् । अपि च ॥ १० ॥ (अ० सं० ३० १/२, ३, ५ से १०)

जातमात्रं विशेष्योल्वाद् बालं सैन्धवसर्पिषा । प्रसूतिकलिशितं चानु बलात्तेन सेवयेत् ॥ ११ ॥

अशमनोर्वादनं चास्य कर्णमूले समाचरेत् । अथास्य दक्षिणे कर्णे मन्त्रमुच्चारयेद्विम् ॥ २ ॥

स्वस्थी भूतस्य नाभिं च वधीयन्ता ॥ ५ ॥

..... स्नापयेत् ॥ ॥ ६ ॥

..... निमज्जाते । ततो दक्षिणतर्जनीया तालूत्रय्यावगुण्ठयेत् ॥ ७ ॥

शिरसि स्नेहपिचुना प्राशयं चास्य प्रयोजयेत् । हरेणुमात्रं मेधादुर्बलाधर्मभिन्त्रितम् ॥ ८ ॥

ऐन्द्रीबाहीवचशङ्खपुष्पीकल्कं घृतं मधु । चामीकरववाहीताप्यप्यथ्यराजीकृताः ॥ ९ ॥

लिष्टान्मधुसुतोतेता हेमधात्रीरजोऽथवा । गर्भोन्मथः सैन्धववला सर्पिषा वामयेततः ॥ १० ॥

प्रजापयेन विधिना जातकर्मणि कारयेत् ॥ ११ ॥ (अ० ह० ३० १/१, २, ५ से ११)

उस प्रसूता स्त्री की अपरा के पालन के लिए कर्म करते हुए, उत्पन्न हुए कुमार के लिए ये कर्म करते योग्य होते हैं (अर्थात् ये कर्म करने चाहिए) । कर्णमूल में दो पथरों को लेकर बजाना तथा शीत अथवा उष्णोदक से मुख का परिधेक अर्थात् गर्मी में शीतोदक एवं जाड़े में उष्णोदक से मुख का परिधेक करना चाहिए । इन (क्रियाओं) से वह (शिशु) क्लेश से रहित होकर अर्थात् प्रसव के समय प्राप्त योनि अथवा यंत्र के पीड़न से उत्पन्न क्लेश से रहित हो प्रार्णों को पुनः प्राप्त करता है (अर्थात् पूर्णरूपेण चैतन्य हो जाता है) । प्राणप्रत्यागत एवं प्रकृतिभूत हो गया हुआ देखकर, उसे स्नान तथा उदक-प्राशन अर्थात् उसके मलमार्ग का शोधन करना चाहिए ।

तत्पश्चात् भलीभाँति कटे हुए नाखून वाली उँगली के ऊपर भलीभाँति धुले हुए कार्पास का आवरण करके बालक के तालु, ओष्ठ, कण्ठ एवं जिह्वा को स्वच्छ करना प्रारम्भ करता चाहिए । मुख स्वच्छ किए हुए इस (बालक) के शिरसतालु (ब्रह्मरन्ध्र के स्थान के ऊपर) को स्नेह से आप्लावित कार्पास पिचु से आच्छादित कर दे । तत्पश्चात् सैन्धव से निर्भ्रत घृत के द्वारा वमन करावे ।

तत्पश्चात् नाभि का उपकल्पन करें (अर्थात् नाभिनाड़ी को काटें) । इसके बाद जातकर्म (वेदोक्त कर्म) करें अर्थात् यथान्याय (यथाविधि या देश, काल, जाति के आधार पर या उनमें प्रचलित) मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके मधु एवं सर्पि का प्रथम प्राशन दें ।

१. शीतोदकेनोष्णोदकेन वेति विकल्पो ऋतुभेदेन त्रेधाः । ग्रीष्मकाले शीतोदकेन, शीतकाले तूष्णोदकेनोत्तरार्धः । क्लेशविहितानिति योनियन्त्रपीडादिक्लेशपरवहन्तः । । उदकप्राशनं मलमार्गाशौचार्थम् । (च० सं० शा० ८/२२ की चक्र० टीका)

मर्हि सुश्रुत ने लिखा है कि उत्पन्न हुए बालक के उल्ब (शरीर के ऊपर आच्छादित श्वेत द्रव्य) को हटाकर मुख को सैन्धव एवं सर्पि से शोधन करके (मुख एवं कण्ठगत स्लेष्मा को दूर करके) मूर्द्धा में घृताक्त पिचु रखें । तत्पश्चात् नाभिनाड़ी का छेदन करें ।

इसके बाद (योनि एवं यंत्र के पीड़न से मूर्धित) कुमार को शीतल जल से (जल से परिधेवन के द्वारा) आश्वसित करके, जातकर्म करने के पश्चात् मधु-सर्पि एवं अनन्त (स्वर्ण) चूर्ण को गुञ्जा-मात्रा^१ में मिला कर अनामिका अङ्गुलि से लेहन करावें । तत्पश्चात् इस बालक का बलात्तेन से अथङ्ग कर इसे स्नान करावें । टीकाकार डक्कण ने ब्रह्मदेव के मत का उद्धरण देते हुए लिखा है कि घृत के स्थान में मूर्द्धा में बलात्तेलाक्त पिचु का धारण करना चाहिए ।

अथाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि अन्य स्त्री उत्पन्न शिशु की बालोपचाराणीय विधि से परिचर्या करे । जो मैं उत्तमतन में वर्णन करूँगा ।

उत्पन्न होते ही बालक का उल्ब सैन्धव एवं सर्पि के द्वारा साफ करें ।

तत्पश्चात् इस अति प्रबल मोह एवं च्चर से पीड़ित सर्वाङ्ग वाले, पीड़ा के अनुरूप रौने में असमर्थ, देह की धातुओं के अशेष (शीण) एवं अनवस्थित (अस्थिर) स्थिति वाले, यौवनावस्था की प्राप्ति की असम्भाव्यता वाले (मृत्यु हो जाने से यौवनावस्था प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठेगा अर्थात् मरणगसन्न) : हाथ, वस्त्र एवं शय्या के स्पर्श को आगे के समान अनुभव करते हुए, भिन्नतर अङ्गों को इधर उधर फेंकते हुए, योनिपुटकों के बीच (प्रसवकाल जन्म) अत्यधिक दबाव के कारण संज्ञा के लीन होने से पुनः मरण का अनुभव करते हुए (बालक) का बलात्तेन से परिधेवन एवं उसके कर्णमूल में अशम का संघटन करना चाहिए ।

प्राणों के प्रत्यागमन से सामान्य प्रकृतिभूत होने पर नाभिनाल का बर्धन (कर्तन) कर स्नान करना चाहिए ।

तत्पश्चात् भलीभाँति नाखून कटी हुई एवं भली प्रकार धोकर, हवा से सुखकर, कार्पास पिचु से अवगुण्डित (लिपटी हुई) दक्षिण तर्जनी उँगली से जिह्वा, ओष्ठ एवं कण्ठ को सुखपूर्वक या धीरे-धीरे साफ करें । तालु को ऊपर उठाकर स्नेह पिचु से शिरसतालु को आच्छादित करें ।

तत्पश्चात् ऐन्द्री, बाह्यी, शंखपुष्पी एवं वचा के कल्क को मधु एवं घृत मिलाकर हरेणु (सूक्ष्म) की मात्रा में, कुशा के अग्रा भाग से अभिमन्त्रित करके, स्वर्ण से निर्मित अथर्वपत्र के द्वारा मेधा, आयु एवं बल को उत्पन्न करने के लिए प्राशन करावें । इसी प्रकार बाह्यी, बला, अनन्ता तथा शतावरी या अन्य औषधियों के चूर्ण का भी प्रयोग करें ।

इसके बाद सैन्धव मिले हुये सर्पि से गर्भोदक का वमन करावें, इससे उर एवं कण्ठ का शोधन हो जाता है, तालुता आ जाती है तथा (आहार की) इच्छा उत्पन्न होती है ।

तत्पश्चात् प्रजापति विधि से जातकर्म करना चाहिए ।

अथाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि उत्पन्न हुए बालक के उल्ब को सैन्धव एवं सर्पि के द्वारा साफ करें तथा प्रसूति-क्लेश-निवारणार्थ बलात्तेन से अनुसेवन कर कर्णमूल में अशम-संघटन करें, तथा दक्षिण कर्ण में इस मन्त्र का उच्चारण करे (मन्त्र पृष्ठ ६२० में देखें) । बालक के स्थिर हो जाने पर नाभि का बर्धन (कर्तन) कर स्नान करावें । तत्पश्चात् दाहिने हाथ की तर्जनी अँगुली से तालु का उत्थमन कर, शिर का स्नेह-पिचु से आच्छादन कर, मेधा, आयु तथा बल के लिए आगे वर्णित प्राशनों को अभिमन्त्रित करके हरेणु प्रमाण की मात्रा में प्रयोग करें । ऐन्द्री, बाह्यी, वचा, शंखपुष्पी का कल्क अथवा चामीकर (स्वर्ण), वचा, बाह्यी, ताल्य (स्वर्णमाक्षिक) एवं पथ्या का चूर्ण अथवा हेम (स्वर्ण) तथा धात्री का चूर्ण घृत

१. उल्बं जरायुं विशेष्य अपनीय, मुखं च विशेष्य निर्मलीकृत्य, तदपि मुखकण्ठागतजरायुकफप्रयत्नेन । । ब्रह्मदेवसु घृताकमिति पदं पलिच्य पिचुं दद्यादित्यत्र 'बलात्तेलाकमिति शेषः' इति व्याख्याति । । आध्यास योनियन्त्रपीडन-मूर्च्छिम् । अनन्तचूर्णं सुवर्णचूर्णं । चूर्णप्रमाणं ज्ञातमात्रस्य गुञ्जामात्रम् ।

(सु० सं० शा० १०/१२, १३ की डक्क० टी०)

एवं मधु के साथ लेहन करायें। तत्पश्चात् सैन्धव चुक घृत से गर्भादक का वमन करायें एवं प्रजापति विधि से जातकर्म करावें।

मर्दिनि हरीति ने संक्षेप में लिखा है कि उत्पन्न होने के बाद बालक का जातकर्म करना चाहिए।

आचार्य भावमिश्र ने लिखा है कि कुल की वृद्ध स्त्रियों के आदेशानुसार व्यवहार एवं परम्परा के आधार पर उत्पन्न बालक के विभिन्न विधान सम्पन्न करने चाहिये।

Caraka says that the attendant should care the new born in following way. She should produce sound by striking or rubbing two stones together near the base of ear of the neonate, sprinkle over face of the child the hot or cold water alternately or on the basis of season i.e. cold water during summer and hot water during winter. With these procedures the child gets relief from the troubles caused by compression in the *yoni* (maternal passage) or from the instruments used at the time of delivery, besides it also regains the life. Once the child has properly regained life and has become totally normal, bath should be given and anal orifice should also be cleaned. Now the woman should wrap the finger, nail of which is already trimmed, with well washed cotton swab and cleanse the palate, lips, throat and tongue of the child with this finger and then cover the *brahmarandhra* (anterior fontanelle) with cotton impregnated with oil. Now *ghrita* mixed with rock salt should be given orally for producing emesis, cutting of umbilical cord and *jātakarma* should be done according to the rituals prevalent in country at that period and also in one's own caste or family, then first feeding with honey and *ghrita* treated with *mantras* should be given.

Suśruta says that after removing *niḥva* (vernix caseosa) from the body and cleaning the oral cavity with rock salt and *ghrita*, *mārdhā* (forehead or anterior fontanelle) should be covered with tampon soaked with *ghrita* or *balā taila*, then umbilical cord should be cut. Now the child unconscious due to compression in *yoni* and by instruments should be revived or encouraged by sprinkling or irrigating cold water, and after performing the *jātakarma* honey, *ghrita* and powder of *amanā* (gold) in the dose of one *guṇī* with index finger should be given for licking, then after massaging with *balā taila* the bath should be given.

Vāgbhata has advised removal of *ulba* (vernix caseosa) with rock salt and *ghrita*. After this the child who is suffering from fever and deep unconsciousness, is unable to cry as per intensity of pain, whose *dhiātus* have decreased and are unstable, attainment of youth is doubtful or is unable to survive long, touch of hand, cloths or bed gives the pain as if being cut by saw and appears to be dying due to unconsciousness caused by compression in *yoni*, should be irrigated with *balā taila*. Striking of two stones together should be done near the base of ear. After proper revival, umbilical cord should be cut and bath given. Now tongue, lips and throat should be gently cleaned with nail trimmed, properly washed, dried and cotton wrapped index finger of right hand. After elevating the *tālu* (palate) bregma should be covered with tampon soaked with fat. Now the child should be given paste of *amdrī*,

१. जातके सुतलोक्षश्च। (ही० सं० वृ० स्था० ५३/६)

२. अथ बाले समुत्पन्ने निदधौति विधिं तथा। यथैव कुलवृद्धबीजवहाहारमप्य ॥ १॥ (पा० प्र० पूर्व० ४)

brāhmī, *śāṅkhuṣṇapūṣṭi* and *vacā* with honey and *ghrita* in the dose of *harenu* (a kind of pea) after consecrating it with the tip of *kūśa*. This preparation is to be fed with a spoon resembling leaf of *asvethā* made of gold for producing/increasing *medhā* (intellect), *gṛi* (longevity) and *balā* (strength). Powder of *brāhmī*, *balā*, *amanā*, *śāṅkhuṣṇā* and other drugs can also be used with similar procedure. Now the child should be made to vomit the liquor *amni* by giving rock salt and *ghrita*. This emesis cleans the throat and chest, produces lightness and also desire for food. After all this the *jātakarma* should be done by usual rituals.

Vāgbhata II giving the description almost like Vāgbhata I has prescribed certain *mantras* to be recited in the right ear of child and also either paste of *amdrī*, *brāhmī*, *vacā* and *śāṅkhuṣṇapūṣṭi* or powders of gold, *vacā*, *brāhmī*, *tāṇya* and *pathyā* or gold and *dhiātī* with honey and *ghrita* in the list of drugs to be given to the child.

Hārīta has advised only *jātakarma*. Bhāwamiśra says that various rituals should be performed according to the advice of old ladies based on the practice and traditions.

विमर्श (Comments)

वृद्धस्त्री में नवजात शिशु-परिचर्या का विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें तत्काल के प्राण प्रत्यागमन, स्नान, प्रच्छर्दन, नाभि-उपकल्पन, जातकर्म, तत्पश्चात् प्राञ्जन या स्नान आदि का सुस्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन दिया गया है। परन्तु आचार्यों में इन प्रक्रियाओं की पूर्वापरा में मत-वैभेद है, यथा महर्षि चक्र नाभि-उपकल्पन शिशु के स्नान एवं वागपट ने प्राणप्रत्यागमन तथा मुख-शोधन के बाद लिखा है, स्नान उसके बाद की प्रक्रिया है। शिशु के जन्म के पश्चात् की प्रक्रियाओं का विभिन्न आचार्यों के मत से क्रमानुसार वर्णन तालिका ११ में दिया जा रहा है। महर्षि सुश्रुत सदृश लब्ध-प्रतिष्ठ शाल्य-वेत्ता ने प्रच्छर्दन तथा अचेष्ट शिशु की चिकित्सा का कोई विधान वर्णित नहीं किया यद्यपि टीकाकार डल्हण ने विषय का संक्षिप्त विवरण दे दिया है।

तालिका-११

क्रम संख्या	चक्र सं०	सुश्रुत सं०	अं० सं०	अ० ह०
१)	कर्णमूल में अशम-संघट्टन	उल्ब-अपनयन	उल्ब-मार्जन	उल्ब-मार्जन
२)	केश्य निवारणार्थ शीतो-बोदक से मुख-परिषेक	सैन्धव-सर्पि से मुख-शोधन	प्रसव-कष्ट-निवारणार्थ बलातैल-अभिषिञ्जन	बलातैल अभिषिञ्जन
३)	प्राणप्रत्यागमनार्थ (अचेष्ट को) कुष्णकपर्णिका शूण्दि से वायु करना	मूर्धा में स्नेहाक्त पिचु-धारा	कर्णमूल में अशम-संघट्टन	कर्णमूल में अशम-संघट्टन
४)	स्नान एवं उदक ग्रहण	नाभिनाड़ी-उपकल्पन	अचेष्ट शिशु की चक्र-	नाल-छेदन
५)	तालु आदि का परिमार्जन	शीतादि क्रिया से	सदृश चिकित्सा	नाभिनाल-उपकल्पन
६)	शिर में तैलाक कार्पास पिचु-धारा	जातकर्म	स्नान	तालु अवगुणन एवं उन्नमन

क्रम संख्या	चरक सं०	सुश्रुत सं०	अ० सं०	अ० ह०
७)	सैन्धव सर्पिं से प्रच्छर्दन	मधु, सर्पिं एवं अनन्ता का प्रथम लेहन	तालु एवं कण्ठ का परि-मूर्धा में स्नेह-पिचु-धारा	मूर्धा में स्नेह-पिचु-धारा
८)	नाभि-उपकल्पन	बलतैल अभ्यङ्ग	मूर्धा में स्नेह-पिचु-धारा	विशिष्ट औषधियों का अवलेहन
९)	जातकर्म	स्नान	विशिष्ट औषधि-प्राशन	चमन
१०)	मधु एवं सर्पिं का प्रथम प्राशन	-	सैन्धव-सर्पिं से चमन-कराता जातकर्म	जातकर्म
११)	-	-	जातकर्म	-

महर्षि चरक द्वारा नाभि-उपकल्पन क्रिया का स्नान एवं प्रच्छर्दन के बाद वर्णन तथा सुश्रुत एवं वाग्भट द्वारा अथर्व-शिशु की चिकित्सा के पूर्व उल्ब-परिमर्जन एवं वाग्भटद्वय द्वारा लेहन के बाद गर्भोदक-चमन का उल्लेख क्रियात्मक दृष्ट्या उचित प्रतीत नहीं होता।

अरुण-संघटन सम्भवतः केन्द्रीय नाडीवहसंस्थान की क्रियाशीलता की परीक्षा के लिए किया जाता है जिसका आयुर्निक प्रतिकूल मोरोज रीफ्लेक्स है। चरक द्वारा वर्णित मलमार्ग-शोधन एवं वाग्भट द्वारा वर्णित तालु-उन्नमन सम्भवतः इन अङ्गों की विशिष्ट परीक्षा के परिचायक हैं।

महर्षि चरक द्वारा वर्णित शीतोष्णोदक के द्वारा मुख-परिषेक के वर्णन को टीकाकार चक्रपाणि ने ऋतुभेद-परिचायक माना है। यह भी सम्भव है कि शीत अथवा उष्ण जल एकान्तर (बारी-बारी से)-प्रयोग के लिए वर्णित हों, क्योंकि नील-क्षामारोघ में इस प्रकार के प्रयोग से त्वचा की संज्ञावह नाडियों को प्रभावित कर प्रत्यावर्तित क्रिया के द्वारा रजस केन्द्र को उत्तेजित करने की प्रथा बीसवीं शती में भी वर्णित मिलती है^१।

Though all the classics have given description of various procedures to be employed in the management of new born child, however, there is difference of opinion in sequence of these procedures as shown in following table.

TABLE

S.No.	C.S.	S.S.	A.S.	A.H.
1.	Striking of Stones.	Cleaning of vernix caseosa.	Cleaning of vernix caseosa.	Cleaning of vernix caseosa.
2.	Irrigation of mouth with cold water.	Cleaning of oral cavity with rock salt and <i>ghrita</i> .	Irrigation of body with <i>bala</i> <i>taila</i>	Irrigation with <i>bala</i> <i>taila</i> .
3.	Resuscitation (described later).	Tampoon application on forehead.	Striking of stones.	Striking of stones.
4.	Bath and cleaning of anus.	Cutting of umbilical cord.	Resuscitation.	Cutting of umbilical cord.

१. हेनरी जेलेट एवं मॉडल द्वारा लिखित "मैनुअल ऑफ मिडविफरी" (पृष्ठ ११५४)

S.No.	C.S.	S.S.	A.S.	A.H.
5.	Cleaning of palate.	Revival with sprinkling of cold water.	Cutting of umbilical cord.	Bath.
6.	Application of tampo on head.	<i>Jātakarma</i> .	Bath.	Cleaning and elevation of palate.
7.	Induction of emesis.	Licking of honey <i>ghrita</i> , gold etc.	Cleaning of throat and elevation of palate.	Tampoon application on forehead.
8.	Cutting of umbilical cord.	<i>Balātaila</i> massage.	Tampoon on head.	Licking of drugs etc.
9.	<i>Jātakarma</i> .	Bath.	Licking of drugs etc.	Induction of emesis.
10.	Licking of honey & <i>ghrita</i> .	—	Induction of emesis.	<i>Jātakarma</i>
11.	—	—	<i>Jātakarma</i> .	—

Description of cutting of umbilical cord after bath etc. procedures (described above) by Caraka and indication for cleaning the vernix caseosa before revival or resuscitation by *Suśruta* and *Vāgbhaṭa*-I and induction of emesis after oral feeding of specific drugs by *Vāgbhaṭa* does not seem to be proper.

Striking of stones near the base of ear might have been advised to examine the condition of central nervous system which resembles to certain extent with Moro's reflex. Advice to clean anus and elevate the palate is probably given to emphasize specific examination of these body parts.

Sprinkling with hot and cold water advised by Caraka has been explained by *Cakrapāṇi* that the hot or cold water is to be used according to specific season. However, it might have been prescribed for alternate use. The practice of stimulating respiratory centre in asphyxia-*livida* through skin reflexes produced by alternate hot and cold bath was prevalent in twentieth century also.¹

जन्मोत्तर अचेद्यु बालक की चिकित्सा-विधि (*Resuscitation of unconscious or asphyxiated child*)

कृष्णकपालिकाशूर्पेण चैनमभिनिष्पुणीयुर्द्व्यचेद्युः स्याद् यावत् प्राणानां प्रत्यागमनम् (तत्तत् सर्वमेव कार्यम्) ॥ (च० सं० शा० ८/४२)

यदि वाचेद्यु एव स्यात्ततः कृष्णकपालिकाया शूर्पेण चैनमभिनिष्पुणीयात्। दीक्षणाकर्णमूले च मन्मथस्योच्चारयेत् ॥ (अ० सं० ३० १/४)

1. "Manual of midwifery" by H. Jellet and D. G. Mandill pp 1154

यदि बालक (जन्मोपरान्त) अचेष्ट हो तो कृष्णकपालिका अर्थात् ईषिका या नल, मुञ्ज, वंश आदि से बनाए हुए शूर्प, अथवा काले किए गए टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के द्वारा हवा तब तक करें जब तक कि प्राणों का प्रत्यागमन न हो जाय (अर्थात् शिशु का सामान्य श्वासोच्छ्वास न प्राप्त हो जाय) एवं यह सभी कार्य करना चाहिए; अर्थात् अचेष्ट शिशु-चिकित्साय कर्णपूर्वों में अस्म-संघटन एवं शोथोष्णोदक से मुख-प्रक्षालन भी करना चाहिए।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि यदि वह बालक अचेष्ट हो तो कृष्णकपालिका शूर्प (अर्थात् वह शूर्प जिसका मध्य भाग धूम का कज्जल लगा कर काला कर दिया गया हो) से उसे हवा करें एवं दक्षिण कर्णमूल में इस मन्त्र का उच्चारण करें (मन्त्र इसी पृष्ठ में है)। अन्यत्र भी लिखा है कि आधान (गर्भाधान) एवं जन्म (प्रसव) के समय होने वाली व्याधि क्लेश या मरण के लिए होती है, अर्थात् उसकी चिकित्सा तत्काल करनी चाहिए।

If the born child is unconscious (asphyxiated) then fanning with winnowing basket made of *kṛṣṇakapālikā* i.e. *isikā* or *nala*, *mūñja*, *vaṃśa* etc. or a blackened broken earthen pot should be done. This fanning and other procedures i.e. striking of stones near the ear-base and irrigation of face with hot or cold water (alternately) should be continued until the neonate is revived or its respiration has established properly.

Vāgphala I expressing almost similar views has advised fanning with the winnowing basket blackened by applying domestic soot and also enchantation of *mantras* (described here-under), at other place has mentioned that the disease developing during fertilization or delivery cause pain or death, in other words this should be treated immediately.

विमर्श (Comments)

महर्षि सुश्रुत एवं अष्टाङ्गहृदयकार ने अचेष्ट बालक की किसी भी चिकित्सा-विधि का वर्णन नहीं किया। सम्भवतः जन्मोपरान्त जातकर्म के पूर्व शीतल जल से (मूर्छित शिशु को-डल्हाण) आशवासन का सुश्रुत तथा मन्त्रोच्चारण का अष्टाङ्ग-हृदय द्वारा निर्देश अचेष्ट शिशु के प्राणप्रत्यागमनार्थ ही दिया गया है।

Sūśruta and Vāgphala II have not described any management specifically to be done for asphyxiated child, however, mention of revival of child by 'sprinkling cold water by Sūśruta and description of *mantras* by Vāgphala II hint towards this topic.

अचेष्ट बालक के चिकित्साय प्रयुक्त मन्त्र (Mantras for resuscitation)

अङ्गादङ्गात् संभवसि हृदयादिभिजायते। आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शतदां शतम् ॥

शतायुः शतवर्षोऽसि दीर्घमायुर्वाप्नुहि। नक्षत्राणि दिशो रात्रिहृश्च त्वाभिरक्षतु ॥

(अ० सं० उ० १/४ एवं अ० ह० उ० १/३ व ४)

तू अङ्ग अङ्ग से उत्पन्न हुआ है, हृदय से उत्पन्न हुआ है आत्मा का ही नाम पुत्र है। तू सौ वर्ष जिग्य, शतायु शतवर्ष का हो (अर्थात् तेरी आयु का एक एक वर्ष सौ वर्षों का हो या तू १०० x १०० = १०००० वर्ष जीवें), तू दीर्घायु प्राप्त करे। नक्षत्र, दिशाएँ, रात्रि एवं दिन तेरी रक्षा करें।

१. कृष्णकपालिका ईषिका नलमुञ्जवंशादिभवा, तत्कृतः शूर्पः कृष्णकपालिका शूर्पः। (च० सं० शा० ८/४२ की चक्र० टीका)
२. कृष्णया धूमकज्जलेन मूर्च्छितमध्या कपालिकया शूर्पेण। (अ० सं० उ० १/४ की इन्दु टीका)
३. आधानजनम।

.....व्याधिरत्नप्रः क्लेशाय मरणाय वा ॥ (अ० सं० नि० १/२१)

Thou is born from different body parts and from the heart. *Ātmā* itself is named as son. Thou live for hundred years, in which each year should be of hundred years (total 10, 000 years). Thou attain longevity. *Nakṣatras* (planets), *diśas* (directions), nights and days should protect thy.

नाभि-उपकल्पन-विधि (Method of cutting the umbilical cord)

अतस्तथा: कल्पनविधिमुपदेश्यामः-नाभिबन्धनात् प्रभृष्टाङ्गुलमभिधानं कृत्वा छेदनावकाशस्य द्वयोरन्तरयोः शर्नङ्गुलीया तीक्ष्णेन सौम्यराजतायसानां छेदनागमयत्तनाभार्धयोगेण छेदयेत्। ताम्रये सूत्रेणोपनिबध्य कठोऽस्म शिशिलमवसृजेत् ॥ (च० सं० शा० ८/४४)

ततो नाभिनाडीमष्टाङ्गुलमायस्य सूत्रेण बद्ध्वा छेदयेत् तत्सूत्रैकदेशं च कुभारस्य ग्रीवायां सम्यग् बध्नीयात् ॥ (सु० सं० शा० १०/१२)

प्रत्यागतप्राणस्य च प्रकृतिभूतस्य नाभिनालं नालाभिबन्धनाच्छतुरङ्गुलस्योर्ध्वं क्षीमसूत्रेण बद्ध्वा तीक्ष्णेन शस्त्रेण वर्धयेत्। ग्रीवायां चैनमासज्जेत्। नाभिं च कुष्ठतैलेन सेचयेत् ॥ (अ० सं० उ० १/५)

रस्यशीभूतस्य नाभिं च सूत्रेण चतुरङ्गुलात्। बद्धोर्ध्वं वर्धयित्वा च ग्रीवायामवसज्जेयेत् ॥ ५ ॥

नाभिं च कुष्ठतैलेन सेचयेत् ॥ ६ ॥ (अ० ह० उ० १/५, ६)

अब उस (बालक) की नाभि के उपकल्पन विधि का उपदेश किया जा रहा है-नाभिबन्धन (नाभि के उदर में संयोग-स्थान) से आठ अङ्गुल स्थान का ज्ञान कर या उस स्थान पर चिह्न लगाकर छेदन करने वाले स्थान को दो (अङ्गुलियों) के बीच में धीरे से ग्रहण करके, स्वर्ण, रजत, लौह या अन्य किसी (धातु) के छेदनाथ बने हुए तीक्ष्ण अर्धभाग शस्त्र से छेदन कर दें। उसके अग्रभाग को सूत्र से भली भाँति बाँध कर (बालक के) कण्ठ में ढीला सा लटका दें।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि उसकी नाभिनाडी को अष्टाङ्गुल नापकर सूत्र से बाँधकर छेदन करें। उस सूत्र के एक भाग को कुभार की ग्रीवा से भलीभाँति बाँध दें। टीकाकार डल्हाण ने लिखा है कि नाभिनाडी को बाँधकर ग्रीवा में बाँधना उससे होने वाले स्वाव के परिहारार्थ है तथा गयी के वचनों का उद्धरण देते हुए लिखा है कि गर्भनाडी को आठ अङ्गुल की दूरी पर सूत्र से न अधिक कसे हुए न अधिक ढीले तरीके से बाँधकर फिर उसे काट कर कुष्ठतैल से परिचरेन करना चाहिए।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि प्राणों के प्रत्यागमन हो जाने एवं प्रकृतिभूत हो जाने के बाद नाभिनाल को नाभि के बन्धन से चार अङ्गुल ऊपर क्षीमसूत्र से बाँधकर तीक्ष्ण शस्त्र से वर्धन (कर्तन) करें, तथा इसे ग्रीवा में (पिंख कर लम्बा होने से बचाने के लिए) लटका दें। नाभि का कुष्ठतैल से (नित्य प्रति) सिञ्चन करें।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि कुभार के स्थिरीभूत हो जाने के बाद चार अङ्गुल की दूरी पर सूत्र से बाँध कर, (नाभिनाल को) काटकर गले से लटका देना चाहिए। नाभि का कुष्ठतैल से अवसेचन करना चाहिए।

The umbilical cord, eight angulas (approx. 4") distal to the umbilicus held gently in between two fingers should be cut with the *ardhadhāra śāstra* (one sided sharp instrument

१. अष्टाङ्गुलमभिधानं कृत्वेति अष्टाङ्गुले चिह्नं कृत्वा। (च० सं० शा० ८/४४ की चक्र० टीका)
२. ततो नाभिनाडीमिति आयस्य अङ्गुल, ग्रीवायां सम्यग् बध्नीयात् सावपरिशारायम्, गयी तु 'गर्भनाडीमष्टाङ्गुलमायस्य नातिगाढं नातिशीथिलमग्रे सूत्रेणान्वध्य वर्धयित्वा कुष्ठतैलेन सिक्त्वा.....' ॥ (सु० सं० शा० १०/१२ की डल्हाण टीका)
३. सूत्रेणसज्जेन्नचल्यपरिहाय ॥ (अ० सं० उ० १/५ की इन्दु टीका)

i.e. knife etc.) made specifically for the purpose with gold, silver, iron or any other metal. The cut end should be tied properly with thread and hung loosely on the neck.

According to Susruta tying of umbilical cord with thread should precede its cutting. Dalhana has explained that hanging of cut umbilical cord with neck prevents further discharge (of blood) and has advised irrigation of cut umbilical cord with *kusjha taila*.

Both the Vāgbhāṭas have advised that only four *angulas* (about 2") distal to the umbilicus the umbilical cord should be cut.

विमर्श (Comments)

महर्षि चरक एवं सुश्रुत द्वारा वर्णित आठ अङ्गुल का प्रमाण कुछ अधिक प्रतीत होता है एवं चरक द्वारा वर्णित नाल का कर्तन के बाद बन्धन उतारना उचित प्रतीत नहीं होता, विशेषकर जब कि नाभिनाल को केवल दो उंगलियों के बीच धीरे से ग्राहण करना है, क्योंकि धीरे से ग्राहण करने पर बाँधने के पूर्व के समय तक उसमें से रक्तस्राव होते रहने की सम्भावना है।

Eight *angulas* distance of umbilical cord given by Charaka and Susruta seems to be slightly more. Tying of umbilical cord after its cutting as advised by Charaka does not seem to be proper, specially when it is to be held only gently between two fingers, because the bleeding may persist in the interval between cutting and tying of umbilical cord.

नवजात शिशु के सट्टा: स्नान के लिए प्रयुक्त विशिष्ट जल एवं स्नान-विधि (Procedure of bath of neonate and water to be used for bathing)

ततो बलतैलेनाभ्यन्म, क्षीरिवृक्षकषायेण सर्वगन्धोदकेन वा रूपहेमप्रतनेन वा वारिणा स्नापयेदेनं कपित्थपत्रकषायेण वा कोष्णेन यशकालं यथादोषं यशविभवं च। (सु० सं० शा० १०/१३)

ततः क्षीरिवृक्षकषायेण सर्वगन्धोदकेन वा तप्ततपनीयरजतनिर्वाणकषायेण कपित्थपत्रकषायेण वा तद्विधेन स्नापयेत् ॥ (अ० सं० उ० १/६)

..... स्नापयेदनु ॥ क्षीरिवृक्षकषायेण सर्वगन्धोदकेन वा ॥ ६ ॥

कोष्णेन तप्ततपनीय निमज्जनैः ॥ ७ ॥ (अ० ह० उ० १/६, ७)

(नवजात शिशु का) बलतैल से अभ्यङ्ग करके, दोष, काल एवं विभव के आधार पर (जिस प्रकार के काल या दोष का अतिक्रमण या जैसी सामर्थ्य हो) ईषदुष्ण क्षीरिवृक्ष के कषाय, सर्वगन्धोदक (एलादिगुण निर्मित कषाय), स्वर्ण या चाँदी से तप्त जल (स्वर्ण या चाँदी को गरम करके जल में बुझाकर प्राप्त जल) अथवा कपित्थपत्र के कषाय से स्नान कराना चाहिए। टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि क्षीरिवृक्ष कषाय का पित्तजन होने के कारण पित्तप्रधान्य में, सर्वगन्धोदक का वातजन होने के कारण वात प्रधान्य में एवं सामर्थ्य का अतिक्रमण हो जाने पर स्वर्ण या चाँदी से तप्त जल अथवा कपित्थ-पत्रकषाय का स्नान के लिए प्रयोग कराना चाहिए।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि क्षीरिवृक्ष-कषाय, सर्वगन्धोदक, तप्त स्वर्ण या रजत से निर्वाहित कषोष्ण जल अथवा कपित्थपत्र-कषाय से विधि पूर्वक (बालक को) स्नान कराए। टीकाकार इन्दु का मत है कि क्षीरिवृक्ष-कषाय,

१. सर्वगन्धोदकः। यशकालं कालानतिक्रमेण।। यथादोषं दोषानतिक्रमेण। क्षीरिवृक्षकषायेण पित्तनेन, सर्वगन्धोदकेन वा वातनेन, विभवानतिक्रमेण रूपहेमप्रतनेन वारिणा, कपित्थपत्रकषायेण वा स्नापयेत् ॥

(सु० सं० शा० १०/१३ की डल्हण टीका)

सर्वगन्धोदक या कपित्थपत्र-कषाय सभी को स्वर्ण या रजत से निर्वाहित करना चाहिए।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि क्षीरिवृक्ष-कषाय या सर्वगन्धोदक या तप्त रजत-निर्मज्जित जल से शिशु को स्नान कराए। टीकाकार अरुणदत्त ने रजत के ही साथ स्वर्ण का भी वर्णन दिया है।

After massaging the child with *balātāila* and giving due consideration to the period, luke warm decoction of *ksūtrīrkṣa* (latex yielding plants) in case of dominance of *pitta*, with luke warm *sarvagandhōdaka* i.e. decoction of *elādi* group of drugs if *vāta* is dominant and decoction of leaves of *kapiṭha* when the child has comparatively less strength.

बालक की सामान्य परिचर्या (General nursing care of the child)

अथ बालं क्षौमपरिवृतं क्षौमवस्त्रास्तृतायां शय्यायां शाययेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/२३)

अहरहश्चास्य श्रोत्रभृङ्गाटकं स्नेहाप्लुतेन प्लुतेन प्रच्छादयेत् ॥ १४ ॥

प्रतिवशसं चैनं क्षौमनिचये संशेयदुच्छिषिके चास्याभिमानितमुद्रकुम्भं स्थापयेत् द्वापक्षयोश्च ॥ १५ ॥

बालक को क्षौम वस्त्र से लपेटकर क्षौम वस्त्र से आच्छादित शय्या पर सुलायें ॥

महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि बालक के कर्ण एवं शंखप्रदेश को स्नेह से भीने हुए पित्तु से आच्छादित करें। बच्चे को मुलायम वस्त्र को गद्दी पर पूर्व की ओर सिर रखकर लिटायें। शिर की ओर तथा (रहने वाले कमरे के) दरवाजे के दोनों ओर मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल से भरे हुए कलश (कमरे में बाँधित आर्द्रता बनाए रखने के लिए) रखें।

The child should be wrapped with linen cloth and made to sleep on a bed covered with linen cloth.

Vāgbhāṭa I says that ear and temporal region of the child should be covered with tampon impregnated with fat (oil or *ghrita*). He should be made to sleep on a cushion made of linen cloth keeping the head on east side. Ewers filled with water and consecrated with *mantras* should be kept towards the head of the child and also on both sides of door of the room (to maintain proper humidity).

रक्षत कर्म (Rakṣatākarma or measures adopted to protect the child against diseases)

अथान्य रक्षां विदध्यात्-आदानीच्छादिकर्कशुपीतुपुरुषकशाखाभिरस्या गृहं समन्ततः परिवारयेत्। सर्वतश्च सूतिकागारस्य सर्वपातसीतण्डुलकणकणिकाः प्रकीरेयुः। तथा तण्डुलबलिहोमः सततमुभयकालं (उभयतः कालम्-पाठभेद) क्रियेतानामकर्मणः (प्राङ्मागकर्माः-पाठभेद)। द्वारे च मुसलं देहर्तुमनुतिश्चीनं न्यसेत्। वचाकुष्ठ-क्षौमकहिङ्गुसर्वपातसीतण्डुलकणकणिकानां रक्षोभ्रमसाय्यातां चौधधीनां पेटुलिकां बद्ध्वा सूतिकागारस्योत्तरदेह-

१. ततोऽनन्तरं तं बालं क्षीरिवृक्षाणां वटदीनां कषायेण तप्तानां तपनीयजलानां निर्वापणेन तत्र तापोपमनोर्णान्कृतेन स्नापयेदिति। अथवा सर्वगन्धोदकोदकेन तपनीयादितेन। अथवा कपित्थपत्राणां कषायेण तद्विधेनेति तपनीयादिकोष्णेन। तपनीयं सुवर्णम्। (अ० सं० उ० १/६ की इन्दु टीका)

२.रूपमुवर्णार्ण्यं निमज्जनैः। (अ० ह० उ० १/७ की अरुणो टीका)

लघामवसृजेत, तथा सूतिकायाः कण्ठे समुद्रायाः, स्थालदुककुम्भपर्यङ्केष्वापि, तथैव च द्वयोर्द्वारपथयोः। कण्ठकण्ठकेऽन्यवान्निस्सिन्दुककण्ठेऽन्यथाऽपिः सूतिकागारस्याभ्यन्तरो नित्यं स्यात्। स्त्रियश्चैनां यथोक्तगुणः सुहृदश्चाजुगुदशहं द्वादशाहं वा। अनुप्रातप्रदानमङ्गलाशीःस्त्रुतिगीतावादिप्रमत्रापानविशदमनुरक्तप्रह्वजनसंपूर्णं च तद्वेश्म कार्यम्। ब्राह्मणश्रवणवेदिकेत, सततमुभयकालं शान्तिं जुहुयात् स्वस्वयनार्थं कुमारस्य तथा सूतिकायाः। इत्येतदक्षौधधानमुक्तम् ॥ (च० सं० शा० ८/४७)

अथ बालं क्षौमपरिवृतं क्षौमवस्त्रास्तृतायां शय्यायां शययेत्, पीतुबद्रीनिम्बपरुषकशाय्याभिर्भूतं परितोजयेत्, मूर्ध्नि चास्याहृदसैलपिचुमवधारयेत्, धूपयेच्चैनं रक्षोर्ध्वधूपैः, रक्षोज्वालि चास्य पाणिपादशिरोग्रीवासववसृजेत्, तिलातसीसर्षपकणांश्चात्र प्रतिकेत्, अधिष्ठाने चानिं प्रचालयेत्, वृणितोपासनीयं चावेक्षेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/२३)

आदारीविदारीबदरीखदित्तिन्मधोलुपरुषकशाय्याभिरेनं वीजयेत्। तामिभश्च समन्ततः सूतिकागारं परिवारयेत्। सर्षपातसीकण्ठकणिकाश्चान्त्वर्हीः प्रतिकेत्। सायंप्रातश्च बलिम् ॥ १६॥

वृणोक्तैश्च गुणुल्वादिभिर्धूपं कुर्वीत। तथा ब्राह्मणोऽथर्ववेदिविश्वाहं शान्तिकर्म कुर्यात्। मायूरीमहामायूरीमा-यांतलकगुधारिणीं चोभयकालं वाचयेत् ॥ १७॥

हिंदुवचातुल्यकारक्षोर्ध्वः पोदलिकामुत्तरदेहल्यामासज्जेत् कुमारस्य च सह मात्रा कण्ठे उच्छीर्षके च। तद्वदार्थो-पायांश्चारीमायां पराजितां च गोरोचनाभिलिखताम् ॥ १८॥

द्वारे च देहलीमनुतिर्यङ्मुसलं निधाययेत्। कण्ठकण्डकान्तिन्दुकैश्चानिं नक्तं दिवं च जागृयात्। तथातुक्ताः स्त्रियः सुहृदश्च। प्रह्वजनसमपूर्णां च तद्वेश्म कार्यम् ॥ १९॥ (अ० सं० उ० १/१६ से १९)

अब इसकी (बालक की) रक्षा का विधान करें-आदारी (घोषकभेद^१), खदिर, कर्कन्धु, पीतु एवं परुषक की शाखाओं को चारों ओर फैला दें (सूतिकागार के चारों ओर लटक भी दें)। सूतिकागार के चारों ओर सर्षप, अतसी, तण्डुल तथा कण्ठकणिका फैला दें एवं नामकरण संस्कार तक (दस दिन तक) लगातार दोनों काल (प्रातः एवं सायं) तण्डुलबालि होम करें। द्वार में देहली पर मुसल को देवा कर के रखें। वचा, कुष्ठ, क्षौमक (क्षौमवस्त्र) हिंदु, सर्षप, अतसी, लशुन एवं कण्ठकणिका आदि रक्षोष्ज (गुणुल आदि) द्रव्यों की पोदली बाँधकर सूतिकागार के द्वार के ऊपर लटका दें। टीकाकार चक्रपाणि ने अन्य मत का उद्धरण देते हुए लिखा है कि देहली का तात्पर्य द्वार का नीचे का काष्ठ होता है। इन्हीं (औषधियों की पोदली) को सूतिका एवं बालक के कण्ठ के इन्चन से सूतिकागार के अन्दर नित्य अनिं प्रज्वलित रखें। यथोक्त गुण बौध दें। कण्ठकण्डक अथवा तिन्दुक काष्ठ के इन्चन से सूतिकागार के अन्दर नित्य अनिं प्रज्वलित रखें। यथोक्त गुण (प्रजनन के सम्बन्ध में वर्णित कुशल, सुहृद) स्त्रियों तथा अन्य हितैषी स्त्रियों दस या बारह दिन तक जागती रहें (अर्थात् सूतिका एवं बालक की निरन्तर देखभाल तथा सुरक्षा करती रहें)। सूतिकागार को लगातार प्रदान (उपहार), मङ्गला (पाठ), आशीर्वाचन, स्तुति, गीत, वादन आदि तथा स्रवच्छ अन्न-पान एवं अनुरक्त, प्रह्व, जन्मसमुदाय से परिपूर्ण रखना चाहिए। कुमार एवं सूतिका के कल्याण की कामना के लिए अथर्ववेद ज्ञाता ब्राह्मणों को लगातार दोनों काल शान्ति होम करना चाहिए। इस प्रकार यह रक्षोविधान कहा गया है।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि बालक को क्षौमवस्त्र में लपेटकर क्षौमवस्त्र बिछे हुए बिस्तर पर सुला दें। पीतु, बदरी,

१. आदारी घोषकभेदः.....आनामकर्मण इति -दशाहं यावदित्यर्थः; दशाहं तु नामकर्म भविष्यति।

रक्षोष्जसमाख्यातानिस्त्रनेन गुणुल्वादीन् ग्रहयति। उत्तरदेहल्याभिलि द्वारापरि अन्ये तु देहली द्वाराधःकाष्ठमाहुः ॥ (च० सं० शा० ८/४७ की चक्र० टीका)

निम्ब एवं परुषक की शाखाओं से पंखा करें, नित्यप्रति सिर में तैलाक पिचु रखें, रक्षोष्ज (वचादि^१) द्रव्यों से धूपन करें, रक्षोष्ज द्रव्यों (की पोदली) को इसके (बालक के) हाथ, पै, सिर एवं ग्रीवा में बाँधें। तिल, अतसी, सर्षप एवं कण चारों ओर बिखेर दें। अधिष्ठान में (पर के अन्दर) अनिं प्रज्वलित करें एवं वृणितोपासनीय (अध्याय) में वर्णित अर्थात् पूर्व की ओर शिर करके सोना, पूर्व की ओर ही दीपक जलाना, माता रखना आदि विधि का पालन करें।

महर्षि चापट ने भी लिखा है कि आदारी (काकहत्ताली^२), विदारी, बदरी, खदिर, निम्ब, पीतु एवं परुषक की शाखाओं से इसे हवा करें, इन्हें सूतिकागार के चारों ओर फैला दें। सर्षप, अतसी एवं कण्ठकणिका को (पर के) भीतर तथा बाहर बिखरा दें। सायं एवं प्रातः बलि दें।

वृण के लिए कहे गए गुणुल, अणु, सर्जस, वचा एवं गौसर्षप आदि से धूपन करें तथा अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मणों से दस दिन तक शान्तिकर्म करावें। मायूरी, महामायूरी, आर्या, रत्नेकुशारिणी आदि का दोनों काल पाठ करें।

हिंदु, वचा एवं गुणुल आदि रक्षोष्ज द्रव्यों की पोदली बनाकर उत्तर देहली में लटका दें। (इन्हीं द्रव्यों की पोदली) कुमार तथा माता के गले में एवं सिरहाने बाँध दें। इसी प्रकार आर्या, पर्णश्वरी, आर्या-अपराजिता (मन्त्र) को गोरोचना से (पूजार्पण में) लिखकर (गले एवं सिरहाने) बाँध दें।

(प्रवेश) द्वार पर देहली में मुसल को तिखा करके रखें। कण्ठकण्डक, तिन्दुक के इन्चन की अनिं को रात-दिन जलायें। अनुरक्त एवं सुहृद स्त्रियों तथा प्रसन्न व्यक्तियों से पर परा रहना चाहिए।

All around the dwelling place of puerperal woman and the child (*śrīkīgāra* or labour ward) the twigs of *ādāri*, *khadira*, *karkandhu*, *pīlu* and *parāṣka* should be hung or strewn and *sarṣapa*, *atāsī*, *tanḍula* and *kaṇṭhakaniḥā* should be strewn. Until the period of naming ceremony i.e. for ten days *tanḍula* bali oblation should be performed continuously morning and evening both the times. A pestle should be placed in oblique position over door-sill. A packet containing *vacā*, *kuṣṭha*, *kṣāumaka*, *hingu*, *sarṣapa*, *atāsī*, *lāsina*, *kaṇṭhakaniḥā* and *gugghu* etc. *rakṣoggha* (antiseptic) drugs should be hung on the upper portion of door-frame or else kept over the door-sill. Small packets of these very drugs should be tied on the neck of the puerperal woman and child, over *sthaḍli* (cooking pot), ewer filled with water, bed and both the panes of door. Fire should be lit daily with the woods of *kaṇṭhakaniḥā* or *tinduka* inside the labour ward. The women having qualities described earlier (under labour) and other well wisher women should remain awaken for ten or twelve days (in order to take special care of mother and child). The labour ward should be full of griffs, auspicious recitations, blessings, praises, playings of music and musical instruments, clean and dainty food and drinkables alongwith loyally devoted and delighted persons. For the fortune and welfare of the mother and child the *brāhmaṇas* possessing knowledge of *ātharvaveda* should perform *śāntihoma* (pacifying oblations to avert or remove evils) morning and evening both the times.

Suśruta says that the child should be wrapped in a linen cloth and made to sleep on

१. रक्षोष्जैर्धूपैर्वादिभिः। अधिष्ठाने सूतिकागारे। वृणितोपासनीयं चावेक्षेति तेन प्राक्शोर्ध्वशयनमजहदीपकदागानि सर्वमन्वापि तत्रोक्त वेदितव्यम् ॥ (सु० सं० शा० १०/२३ की इल्ल० टीका)

२. आदारी काकहत्ताली। वृणोक्ता गुणुल्वादयः सूक्ष्मस्थाने शस्त्रकर्मविधौ गुणुल्वागुसर्जसवचागौसर्षपैत्यादिना पठिताः।। (अ० सं० उ० १/१६ व १७ की इट्ट टीका)

a bed covered with linen cloth. Fanning with twigs of *pīla*, *budār*, *nimba* and *parīṣka*, application of lampoon impregnated with oil over head and fumigation with *rakṣogha* drugs should be done. Small packets made with these very drugs should be tied on arms, legs, head and neck of the child. *Tila*, *asaī*, *sarṣapa* and *kāṇa* (pieces of rice) should be strewn all around. Other management advised for wounded or ulcerated person such as position of head (during sleep), burning lamp and earlands all on eastern side etc. should also be done.

Vagbhata I has followed Caraka, however, he has included *vidār* along with *ādār* etc. drugs, and also has advised fanning with these twigs along with fumigation with *guggha*, *sanjaraṣa*, *vaca*, yellow *sarṣapa* etc. *rakṣogha* drugs prescribed for a wounded person. For *śāntikarma* (pacifying acts to avert evils) he has advised recitation of *māyūr*, *mahāmāyūr*, *ārya*, *raṇaketiudhāyūr* (specific procedures of recitations) etc. and tying of small packets of *hingra*, *vaca* and *turpaka* on the head and neck of the child and mother, and on the upper door sill; and also *bhūjāpātara* having *ārya*, *parāśabarā*, *ārya-aparāyā* etc. hymns scribed with *gorocana* (a bright yellow pigment prepared from the urine or bile of a cow or found in the head of a cow) on the head and neck.

षष्ठी रात्रि का रक्षकर्म (*Rakṣākarma or protective measures to be done on ṣaṣṭhī rātri or on 6th night after birth*)

षष्ठीरात्रिं विशेषेण कृतरक्षकालक्रियाः । जागृतुर्बान्धवास्तस्य दधतः परमां मुदम् ॥

(अ० सं० उ० १/२६)

षष्ठी ॥ बान्धवास्तत्र ॥ (अ० सं० सदृश ही) (अ० ह० उ० १/२१)

(जन्म की) छठवीं रात्रि को विशेष कर बलि आदि के द्वारा रक्षकर्म करना चाहिए । बन्धु-बान्धव प्रसन्न रह कर जागरण करें ।

On 6th night after birth, *rakṣākarma* by offering sacrifices etc. should specifically be done. The family members and friends should remain awoken happily.

विमर्श (Comments)

सम्पूर्ण रक्षकर्म का उद्देश्य माता एवं बालक को विभिन्न औपसर्गिक व्याधियों से बचाना है । प्रयुक्त औषधियाँ सम्भवतः बालावरण को कीटाणु-रहित या उनकी आक्रमक शक्ति का ह्रास कर देती हैं । ६ दिन तक टेढ़े-से व्याधि का भय अत्यधिक रहता है, सम्भवतः इसी दृष्टिकोण से यह विशिष्ट रक्षकर्म किन्ना गया हो अथवा यह वर्णन प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का परिचायक है ।

Entire *rakṣākarma* is aimed at offering protection from infective disorders to the mother and child. It is just possible that various drugs prescribed for the purpose might be either making the environment free from infective organisms or else reduce the virulence of these organisms.

The sixth day's rituals might have been advised because the risk of tetanus to the neonate is maximum upto this period, if not, this might be reflecting the social custom prevailing even to-day.

शिशु की जन्म से लेकर चतुर्थ दिवस तक की आहार व्यवस्था (*Feeding schedule of neonate from first to fourth day after birth*)

तद्यथा-मधुसर्पिणी मन्त्रोपमन्त्रिते यथापानाय प्रथमं प्राशितुं दद्यात् । स्तनपान ऊर्ध्वमेतेनैव विधिना दक्षिणं पातुं पुरस्तात् प्रयच्छेत् । अथतः शीर्षतः स्वापयेदुदकुक्षं मन्त्रोपमन्त्रितम् ॥ (च० सं० शा० ८/४६)

तस्मात् प्रथमेऽह्नि मधुसर्पिर्नन्तामिश्रं मन्त्रपूर्तं विकालं पायेत्, द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं सर्पिः, तृतीये च ; ततः प्राङ्निषिद्धस्तनप्यास्य मधुसर्पिः स्वपाणितलसमिमतं द्विकालं पायेत् । (सु० सं० शा० १०/१५)

तस्मात् प्रथमेऽह्न-नन्तामिश्रिते मधुसर्पिणी मन्त्रपूर्ते विकालं प्राशयेत् ॥ द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं सर्पिस्तृतीये च ॥ १२ ॥

ततः प्राङ्निवातिलस्तस्य स्वपाणितलसमिमतं सर्पिर्द्विकालं दापयेदन्तरं च स्तन्यमिष्टतः ॥ १३ ॥

(अ० सं० उ० १/१२, १३)

प्रथमदिवसे तस्मात् विकालं मधुसर्पिणी ॥ १२ ॥

अनन्तामिश्रिते मन्त्रपाविते प्राशयेच्छिशुम् । द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं तृतीये च घृतं ततः ॥ १३ ॥

प्राङ्निषिद्धस्तनप्यास्य तत्पाणितलसमिमतम् । स्तन्यगुपानं द्वौ कालौ नवनीतं प्रयोजयेत् ॥ १४ ॥

(अ० ह० उ० १/१२ से १४)

वेदमन्त्रों से अभिमन्त्रित करके मधु एवं सर्पि का प्रथम प्राशन देना चाहिए । इसके बाद इसी विधि अर्थात् मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके^१ दक्षिण स्तन में बालक को पीने के लिए लगायें । इसके शीर्ष की ओर मन्त्रों से उपमन्त्रित जल से पूर्ण कलश की स्थापना करें ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि प्रथम दिवस मन्त्र से अभिमन्त्रित, मधु-सर्पि का अनन्ता (स्वर्ण, दूर्वा या यवासक) के साथ मिश्रित करके तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एवं अपान्त) प्राशन दें । दूसरे दिन लक्ष्मणा से सिद्ध सर्पि तथा वही तीसरे दिन भी दें । तत्पश्चात् (चौथे दिन) पहिले माता का दूध न पिलाए गए उस (बालक) को उसकी हथेली में आगे योग्य मात्रा में मधु एवं सर्पि दो बार पिलायें । टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि चौथे दिन प्रातः एवं मध्याह्न मधुसर्पि का प्राशन, तत्पश्चात् तृतीय काल से आरम्भ करके पौर्वाह्न आदि दिन यथेष्ट स्तनपान करायें^२ ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी सुश्रुत सदृश ही लिखा है कि पहिले दिन अनन्ता मिश्रित मधु-सर्पि को मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके तीनों कालों में प्राशन दें । दूसरे एवं तीसरे दिन लक्ष्मणा से सिद्ध सर्पि तत्पश्चात् पहिले स्तनपान न कराए गए बच्चे को दो काल उसके पाणितल में आगे योग्य मात्रा में मधु-सर्पि तत्पश्चात् यथेच्छ मात्रा में स्तनपान करायें ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि पहिले दिन मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके अनन्ता मिश्रित मधु-सर्पि का तीनों कालों में प्राशन करायें । दूसरे एवं तीसरे दिन लक्ष्मणा से सिद्ध घृत दें ; क्योंकि इस काल तक माता में क्षीर का अभाव रहता है^३ । तत्पश्चात् पहिले से स्तनपान के लिए निषिद्ध या स्तनपान न कराए गए शिशु को स्वपाणितलसमिमत नवनीत दो कालों में प्रयुक्त करके स्तनपान करायें ।

Caraka says that on first day of birth first feeding of honey and *ghrita* consecrated with *mantras* should be given, there-after with similar procedure (i.e. consecration with *mantras*)

१. यथापानमिति यथागमं मन्त्रोपमन्त्रिते । एतेनैव विधिर्नस्तिस्त(न्य)मयमिमन्त्रितं पायेदित्यर्थः ।

२. लक्ष्मणं दिवसे प्रातर्मध्याह्निलक्षणे मधुसर्पिः प्राशयेत्, तदनन्तरं चतुर्थदिवसस्य तृतीयकालमारभ्य षष्ठ्यमदिरिक्तेषु यथेष्टं स्तनपानं कारयेत् । (सु० सं० शा० १०/१५ की डल्ह० टीका)

३. यत एवं दिनत्रिचतुर्मासं क्षीराभावः ॥ (अ० ह० उ० १/१२ की अरुण० टीका)

(च० सं० शा० ८/४६ की चक्र० टीका)

right breast should be offered for suckling. An ewer filled with water and consecrated with *mantras* should be kept towards head of the child.

Susruta and both Vagbhata say that on first day honey and *ghrita* mixed with *amanata* (gold, *dirva* or *yawāsaka*) and consecrated with *mantras* should be given thrice. On second and third day *ghrita* medicated with *lakṣmanā*, on fourth day twice i.e. morning and noon honey and *ghrita* in the amount which fills the palm of neonate, there-after from evening free breast feeding, as desired by the child, should be started.

विमर्श (Comments)

महर्षि चक्र ने जातकर्म के तुरन्त बाद मधु-सर्पि का प्राशन तत्क्षणात् स्नानपान का विधान दिया है। महर्षि सुश्रुत एवं वाग्भट ने जातकर्म के पश्चात् मधु-सर्पि एवं अनन्ता का प्राशन, तत्पश्चात् प्रथम दिन इन्हीं चीजों को केवल तीन काल एवं दूसरे तथा तीसरे दिन भी केवल लक्ष्मणा से सिद्ध घृत बताया है। त्रिकाल से दिन के तीनों काल अर्थात् प्रातः, मध्याह्न एवं सन्ध्या अर्ध निकलता है इन कालों में उपर्युक्त प्राशन कितनी बार देना है ऐसा निर्देश न होने से यह माना जा सकता है कि इन वस्तुओं को अनेक बार भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि तीनों कालों में एक बार ही प्रयोग माने तो शिशु की आवश्यकताओं विशेषकर जलीयांश की आवश्यकता की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, यदि अनेकों बार देने का अर्थ ग्रहण करें तो इतने अधिक मधु-सर्पि का प्रयोग सम्भवतः हानिकारक होगा। क्रियात्मक दृष्ट्या महर्षि चक्र का मत मान्य है। आधुनिक काल में प्रसव के तत्काल बाद ही माता एवं शिशु के स्वस्थ होने पर स्नानपान कराना जाता है।

सभी आचार्यों ने मधु-सर्पि का प्रयोग निर्दिष्ट किया है। मधु मधुमक्षिकयां द्वारा विभिन्न पुष्पपरागों को एकत्र कर निर्माण किया जाता है। पुष्पपराग ज्ञात प्रतिजानात्मक (पेप्टोजेनिक) द्रव्य है। यह सम्भाव्य है कि विभिन्न प्रकार के पुष्प-परागों से निर्मित मधु के प्रयोग से स्त्रीर की रोमप्रतिशेधान्मक शक्ति की वृद्धि होती हो। सर्पि आन्त्र-स्थित शूण-मल को बाहिःनिस्सृत कर आन्त्र-शोषण में सहायक होता होगा।

Feeding schedule for first three days advised by Susruta and both the Vagbhata does not seem to be proper, because respective feeds are advised thrice or during three periods i.e. morning, noon and evening. If it is inferred that any number of feeds can be given during these periods, then amount of honey and *ghrita* ingested by the neonate would be much beyond his digestive capacity, however, if the feeding is given only thrice, then it will not be sufficient for nourishment specially for requirement of water. Advice of Charaka i.e. breast feeding from first day is more logical. Breast feeding at the earliest possible time after delivery to a healthy neonate by healthy mother is said to be beneficial for both. All the authors have advised use of honey and *ghrita*. Honey is collected from pollens of various flowers by bees. Pollens are known antiseptic substances, it is possible that this honey might be containing antigens thus produces non-specific immunity in the child; the *ghrita* might be helping in clearing the meconium from bowels.

शिशु का नामकरण संस्कार (Naming ceremony of the child)

दशमे त्वह्नि सपुत्रा स्त्री सर्वगन्धर्वैर्गौरसर्वलक्ष्यैश्च स्नाता त्वह्नात्पुत्रचिह्नं परिधाय पवित्रेष्टलघुविचित्र-भूषणवती च संसृष्य भङ्गुलाभुचितामवीयन्ता च देवता शिखिनः शुक्लवाससोऽप्यङ्गुलं बाह्यपानं स्वस्तिवाचायित्वा कुमारमहतानां च वाससां संवधे (कुमारमहतेन वाससाऽऽच्छादयेत्-पाठभेद) प्राक्शिरसमुदकशिरसं वा संवधेयं देवतापूर्वं द्विजातिभ्यः प्रणमतीत्युक्त्वा कुमारस्य पिता द्वे नामनी कारयेत्प्राक्षत्रिकं नामाभिप्रायिकं च। तत्राभिप्रायिकं

षोषदाद्यान्स्थान्ममूष्मानं वाऽवृद्धं विपुष्पानूकमनवप्रतिष्ठितं, नाक्षत्रिकं तु नक्षत्रदेवता समानाख्यं द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा ॥ (च० सं० शा० ८/५०)

ततो दशमेऽह्नि मातापितरौ कृतमङ्गलकौतुकौ स्वस्तिवाचनं कृत्वा नाम कुर्वातां यदभिप्रेतं नक्षत्रनाम वा ॥

(सु० सं० शा० १०/२४)

दशमे द्वादशे वाहिनि गोत्रावातेः शुभैः शुभैः । पितापत्यस्य नाम च ॥ २७॥

दिने शततमे वाख्यां पूर्णं संवत्सरोऽथवा । विभ्रतोऽङ्गैर्मनोहालरोचनगालचन्मन् ॥ २८॥

पूर्यं विपुष्पानूकमादौ षोषवदक्षरम् । अवृद्धं कृतमूष्मान्मनरातिप्रतिष्ठितम् ॥

नक्षत्रदेवतायुक्तं तदेव तु न केवलम् । मङ्गल्यमन्त्रान्तस्य न दुष्टं न च तद्भित्तम् ॥ २९॥

पुंसो विसर्जनीयान्तं समवर्णां स्थियाः पुनः । विषमाक्षरमङ्कुरं विसृष्टार्थं मनोरमम् ॥

सुखाद्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादभिधानवत् ॥ ३०॥ (अ० सं० उ० १/२७ से ३०)

दशमे दिवसे पूर्णं विधितिः स्वकुलीचितैः । कारयेत्सुतिकोत्थानं नाम बालस्य चाऽर्चितम् ॥ २२॥

विभ्रतोऽङ्गैर्मनोहाऽन्तरोचनाऽगुप्तचन्दनम् । नक्षत्रदेवतायुक्तं वाच्यं वा समाक्षरम् ॥ २३॥

(अ० ह० उ० १/२२, २३)

दशवें दिन प्रसूता स्त्री अपने बालक के साथ सर्वगन्ध औषधियों, श्वेत सर्प एवं लोष (निर्मित जल) से स्नान, हलके, अहल तथा स्वच्छ वस्त्र एवं पवित्र, हलके, मनोहृत एवं विचित्र (अनेकों प्रकार के) आपूषण धारण, मङ्गल द्रव्यों का स्पर्श, उचित देवताओं की पूजा (अर्थात् जिन देवताओं की हर समय पूजा करती हो उन्हीं की पूजा) एवं अग्नि अथवा शिखाधारी (अमुण्ड), श्वेत वस्त्रधारी, अव्यङ्ग (सर्वाङ्ग सम्पूर्ण) ब्राह्मणों की पूजा कर तथा ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन करा करा, कुमार को बिना फटे हुए कपड़ों के सज्ज्य अर्थात् कपड़ों के पतों से निर्मित मोटी गद्दी में रख कर, पूर्व या उत्तर की ओर शिर (मुख) कर्क के बैठे (बालक को सुलाकर स्त्री स्वयं बैठे) । यह बालक पहले देवता बाद में ब्राह्मणों को प्रणाम करता है ऐसा कह कर, पिता दो नाम एक नाक्षत्रिक तथा दूसरा अभिप्रायिक (नित्य प्रति प्रयुक्त होने वाला) रखे । अभिप्रायिक नाम के आदि में षोष वर्ण (ह, य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, न, झ, भ, घ, ङ, ध, ज, ब, ग, ङ, ट), एवं अन्त में अन्त्य (य, व, र, ल, आदि) या ऊष्माल (श, ष, स, ह आदि) अक्षर हों । वह नाम अवृद्ध अर्थात् आ, ऐ, औ के प्रारम्भ से रहित, कुल के तीन पुरतों के अनुकूल और प्रसिद्ध हो । नाक्षत्रिक नाम नक्षत्रदेवता (जन्म के नक्षत्र या देवता) के समान दो या चार अक्षर वाला होना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत ने संक्षेप में लिखा है कि दसवें दिन माता-पिता मङ्गल एवं कौतुक (विशिष्ट पूजन-विधि) स्वस्ति-वाचन करके अभिप्रेत एवं नक्षत्र नाम रखे ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि दसवें या बाराहवें दिन गोत्राचारानुसार शुभ दिन के शुभ मुहूर्त में अथवा सौवें दिन या एक वर्ष पूरा होने पर पिता पुत्र का नामकरण करे । उस दिन अङ्गों में मनोहा, आल, रोचना, आगर तथा चन्दन का लेप करे । नाम पूज्य, तीन पुरतों के अनुकूल, षोष युक्त प्रथम अक्षरवाला, अवृद्ध (बहुत बड़ा न हो या वृद्ध रहित), अंत में ऊष्म वर्ण वाला, शत्रु वर्ग में अप्रतिष्ठित तथा नक्षत्र एवं देवता से युक्त होना चाहिए । इतना ही नहीं वह नाम मङ्गल-वाची, मध्य में अन्त्य वर्णवाला होना चाहिए । दूषित एवं तद्धित वर्ण वाला नहीं होना चाहिए । पुत्र का नाम विसर्जनीयान्त एवं समवर्ण का तथा स्त्रियों का नाम विषम अक्षरों वाला, अङ्कुर, स्पष्ट अर्थ वाला, मनोरम, सुखपूर्वक उच्चारण किए जाने वाला होना चाहिए, उसके अन्त का वर्ण दीर्घ हो तथा उच्चारण में आशीर्वाद जैसा प्रतीत हो ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने संक्षेप में लिखा है कि दशम दिन पूर्ण हो जाने पर अपने कुल की विधि के अनुसार सुतिकोत्थान

१. उचितामिति या यस्य देवता सदा पूज्यतेनेतिचाता तामवीयन्ता । शिखिन इति पावकान्, किंवा शिखा चूड़ा वढतो ब्राह्मणन-मुण्डान् ॥ (च० सं० शा० ८/५० का चक्र० टीका)

करके बालक का नामकरण करें। (बालक के) अङ्गों में मनोहा, आल, रोचना, अगर तथा चन्दन का लेप करके नक्षत्र (जन्म के नक्षत्र), देवता से युक्त वाच्यों के नाम के मृदुल सम अक्षरों वाला नाम रखें।

महर्षि हारीत ने संक्षेप में लिखा है कि बारहवें दिन (मङ्गल कर्म करके) नामकरण-कर्म करें।

On tenth day after delivery, the woman alongwith her child should take bath with water medicated with *sarvagandha* drugs, yellow *sarsapa* and *lodhra*; dress herself with light, intact, clean garments and sacred, desired, light and splendid ornaments. Now she should touch auspicious objects, worship the god (whom she has always worshipped), fire and *brāhmanas* possessing lock of hair on crown of their head, having all the body parts intact and wearing white garments. After having recitations for welfare and prosperity by *brāhmanas* and placing the son on pack of intact cloths, she should sit keeping head of the child towards north or east. The child has offered obeisance to diety and *brāhmanas*, saying this the father should give him two names i.e. *nākṣatrika* (based on the planets of birth) and *abhiprāyika* (popular to be used daily). The popular name should begin with *ghoṣa varṇa* (*ha, ya, va, ra, la, ṇa, ma, ṇa, ṇa, jha, bha, gha, dha, ja, ba, ga, da, da*), and end with *antastha* (*ya, va, ra, la*) or *ūṣmāna* (*śa, śa, sa, ha*). The name should not have a letter with *vṛddha* i.e. *ā, ai, ou*, be identical with the names of three generations and be famous. The *nākṣatrika* name should be according to the planet of birth consisting of two or four letters.

Suśruta says that parents of the child after performing *māṅgala* and *kāutika* worships (worships with specific rituals) and having recitations for welfare and prosperity should give two names i.e. *abhiprāya* and *nākṣatra*.

Vāgbhata I has mentioned that the father of child should perform the naming ceremony on auspicious period of tenth, twelfth or hundredth day or after completion of one year according to traditions of one's family. On the day of ceremony body of the child should be anointed with *manohva, āla, rocanā, agaru* and *candana*. The name should be venerable, benedictory, uncommon with the enemies and consists the letters described by Caraka. The name should not have *daṣṭa varṇa* (inauspicious or defective letters) or *taddhita varṇa* (an affix added to primary bases to form derivative or secondary bases from them). The name of boy should consist even number of letters and end with *visarga* (a symbol in writing, representing a hard aspiration and marked by two perpendicular dots). The name of girls should possess odd number of letters, not be cruel, be distinct in sense or meaning, attractive, and easy to pronounce. Its last letter should consist *dīrgha varṇa* (*ā, ī, ū* etc.) and should echo like blessing.

Vāgbhata II and Hārīta have advised the naming ceremony to be held on tenth and twelfth day respectively.

विमर्श (Comments)

नामकरण संस्कार का आचार्यों ने दशम दिन ही विधान दिया है। अष्टाङ्गसंग्रह-चर्चित दिनों का अन्तर सम्भवतः पुस्तक-लेखन-स्थान एवं काल के वैविध्य के कारण हो।

१. हुताश्राहं तथापुनः । नामकर्मकृत्वा । (हो० सं० तृती० ५३/६)

Difference in the days of naming ceremony reflect the customs prevailing in the area or period to which author belonged.

अन्य परिचर्या (Other general management)

नामकरण के पश्चात् आचार्यों ने बालक को आयु के प्रमाण के ज्ञानार्थ उसको शारीरिक परीक्षा तथा कुमारगार में कुमार का रखना, कुमारधार के द्वारा शिशु का पालन, कुमारगार (चि० ३१) तथा कुमारधार की विशेषताओं के वर्णन के उपरान्त बालक के सूतिका या कुमारगार से बाहर निकलने से लेकर अन्य परिचर्या एवं बालक की शैय्या, खिलौने, क्रीडा-स्थल, उपवेशन, अन्नप्राशन, कर्णवेधनादि सभी संस्कारों का विस्तृत वर्णन किया है। बालक की आयु, बल, बुद्धि एवं मेधा के वर्धनार्थ अनेकों स्वर्ण-युक्त या अन्य औषधियों के प्राशन भी उल्लिखित हैं।

मातृशरीर से पुष्पक होने के क्षण से लेकर सम्पूर्ण बालावस्था के विभिन्न आहार-विहार एवं व्याधियों का भी विस्तृत विवरण संहिताओं में उपलब्ध है। महर्षि चरक ने जात-शिशु के व्याधि-रहित होकर सामान्य वृद्धिकारक एवं व्याधि-उत्पन्नक कारणों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए लिखा है कि जातिस्त्रीय अध्याय (शरीरस्थान अध्याय ८) में उपदिष्ट आहार एवं उपचार शिशु के लिए अविकारकारी तथा वृद्धिकर होते हैं। विषम रूप से सेवित (आहार एवं उपचार) उत्पन्न शिशु

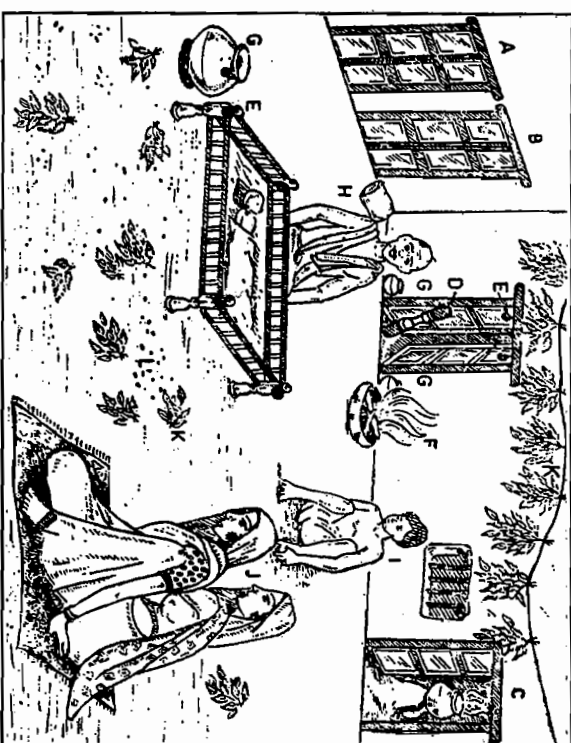


Fig. (31) : Well ventilated and protected against the *grahas* etc. *Kumārādhārā* or abode for new-born having separate (A) latrine; (B) bath room; (C) kitchen; (D) with a pestle placed near the door in oblique position; (E) the packets of drugs are tied over the door, ewer and bed of the child; (F) fire is constantly burning; (G) water filled ewers are placed near the head of the child and door; (H) *Brāhmanas*; (I) *Kumārādhārā* or male attendant and (J) few women remain present there; (K) The twigs of *ādānī, nimba* etc. plants are also hung and strewn, (L) Yellow *sarsapa* etc. are strewn all around.

को तत्काल ही उसी प्रकार हनन कर देते हैं जिस प्रकार को शीघ्र ही सेपित किए गए हुए, अप्रतिष्ठित (जो सुदृढ़ न हो) मूल वाले वृक्ष को बात एवं आतप^१। विषय बालरोग-विशेषज्ञ के अधिकार-क्षेत्र का होने के कारण अप्रसंगिक है अतः वर्णन नहीं किया जा रहा।

After naming ceremony, physical examination of the child to assess longevity, stay in *kumārāgāra* (a house or room specifically constructed or maintained for the child), care by *kumārādhāra* (male attendant to look after the child), detailed description of *kumārāgāra* (fig. 31) and *kumārādhāra* and period for leaving the *kumārāgāra* or *stūtiāgāra* etc. have been described by all the authors. Besides, special bed for child, his toys and playground, *upavēśana*, *annapravēśana* and *kāmapravēśana* etc. *samskāras* (specific rituals performed while making the child sit for the first time, beginning of cereal feeding and piercing of ear respectively), have also been elaborated. Specific recipes of gold or other medicine for longevity, inhamcement of *bala* (strength), *buddhi* (intellect) and *medhā* (memory), diet required and diseases inflicting during entire span of childhood have also been described. Caraka giving short description of the factors responsible for proper growth or diseases of the new born says that dietetics and other mode of life prescribed for the woman during antenatal period are congenial to the new born and beneficial for proper growth and development. Abnormally used dietetics and mode of life kill the new born in the same way as a recently planted plant, not possessing strong roots, gets destroyed by wind and heat. Since the subject comes under the jurisdiction of pediatrician, hence is not being described here.

नवजात शिशु की असम्यक् परिचर्या जन्य व्याधियाँ (Diseases afflicting the child due to improper care immediately after birth)

नवजात शिशु को बालकों में होने वाली सभी व्याधियाँ हो सकती हैं जिनका वर्णन बालरोग की पुस्तक का विषय है। इस स्थान पर केवल उन्हीं विकारों का उल्लेख किया जायगा जो नवजात शिशु की परिचर्या में असावधानी के कारण हो सकते हैं। अचेष्ट बालक की चिकित्सा का वर्णन पूर्वपृष्ठों में किया जा चुका है। उपशीर्षक, गर्भोदक के सम्यक् वमन न करने से उत्पन्न उत्पन्न व्याधि तथा नाभि के असम्यक् उपकल्पनादि जन्य व्याधियों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

Method of resuscitation has already been described, *upasthāśaka*, diseases of umbilicus and *ulbaka* (caused due to improper enesis of liquor amni) only are being described here, because these arise due to negligence in care of new born child.

उपशीर्षक (Upasthāśaka)

दुग्ध वायु के कारण गर्भ अथवा नवजात शिशु के कपाल में सवर्ण एवं नीरज शोफ उत्पन्न हो जाता है जिसे उपशीर्षक कहते हैं।

१. तस्याहारोपचारौ जातिस्त्रीयोपदिष्टाविकारकौ चाभिर्वृद्धिकरौ भवतः ॥ २५॥
ताभ्यामेव च विषमसेविताभ्यां जातः सद्य उपहन्त्यते तलीवाचित्यप्रतीपितौ वातातप्याभ्यामप्रतिष्ठितमूलः ॥ २६॥
(च० सं० शा० ६/२५, २६)
२. (अ) कपाले पद्मे दुग्धे गर्भस्थस्यापि ज्ञायते। सवर्णो नीरजः शोफस्तं विद्यादुपशीर्षकम् ॥ (गर्भस्थस्यापिशब्दज्ञातस्यापि-इन्द्र) (अ० सं० उ० ३०/१४)
- (आ) कपाले पद्मे दुग्धे गर्भस्थस्यापि ज्ञायते। सवर्णो नीरजः शोफस्तं विद्यादुपशीर्षकम् ॥ (अ० इ० उ० २३/२१)

नवजात शिशु-परिचर्या विज्ञानीय

यह प्रसव-काल में उत्पन्न शिशु के शिर में होने वाले 'कपूट सॉक्सडेनिअम' का वर्णन प्रतीत होता है।
Vitiated *vāyu* produces painless swelling of body-colour over the head of the fetus or newborn, which is known as *upasthāśaka*.

This appears to be description of caput succedaneum.

नाभिगत व्याधियाँ (Diseases of umbilicus)

१) नाभिपाक-चिकित्सा (Treatment of nabhipāka or suppuration of umbilical wound)

- (१) नाभिपाक में हरिद्रा, लोष एवं मधुपट्टी के साथ त्रिपुण्ड्र^{३,४} अथवा त्रिपुण्ड्र एवं सुतार^१ अथवा रयामा^३ के कल्क से निर्मित तैल से अच्यङ्ग करें।
- (२) उपर्युक्त औषधियों के चूर्ण का अवचूर्णन करें^{१,३,३*}।
- (३) छाग-शकृत को जलाकर उसका अवचूर्णन करें^३। योगालाकर में 'दग्धेन' के स्थान में दुग्धेन अर्थात् छाग-शकृत को दुग्ध के साथ मिलाकर प्रयोग वर्णित है, पर यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है क्योंकि दुग्ध मिलाकर अवचूर्णन नहीं हो सकता अतः 'दग्धेन' पाठ ही युक्तिसंगत है^४।
- (४) क्षीरी वृक्षों के त्वक्-चूर्ण का अवचूर्णन करें^{३*}।
- (५) चन्दन-रेणु का अवचूर्णन करें^{३*}।
- i) Oil prepared with pestled *haridra*, *lodhra* and *madhupatī* with either *prīyangu* or *suradāru* or *śyāmā* should be applied.
- ii) Fine powders of following should be sprinkled over wound—
 - a) Drugs mentioned for preparing above oil.
 - b) Ash of burnt pellets of goat.
 - c) Stem-bark of *ksīri vṛkṣas* (latex yielding trees).
 - d) Dust of *candana*.

२) नाभि के असम्यक् उपकल्पन से उत्पन्न व्याधियाँ एवं उनकी चिकित्सा (Diseases developing due to improper cutting of umbilical cord and their treatment)

अ) व्याधियाँ (Diseases)

असम्यक् कल्पने हि नाडा आयामव्यायामोत्पिडता पिण्डलिका विनामिका विजृम्भिकाबाधेभ्यो भयम् ॥

(च० सं० शा० ८/४५)

१. तस्य चेनाभिः पच्यते, तां लोभप्रमुकाप्रियङ्गुसुदारहरिद्राकल्कमिद्धेन तैलेनाच्यन्ता, एषामेव तैलीषधानां चूर्णं नावचूर्णयेत् ॥
(च० सं० शा० ८/४४)
२. यष्टीलोभनिशाशयानाकल्कपक्वेन सेचयेत्। नाभिं पके तु तैलेन तच्चूर्णोष्णवचूर्णयेत् ॥ (अ० सं० उ० २/८८)
३. नाभिपाके निशालोभप्रियङ्गुमुष्कैः शृणु। तैलमप्यञ्जेन शस्त्रोभिशोष्यवपुनतम् ॥
दग्धेन छागशकृता नाभिपाकञ्चवचूर्णम्। त्वक्चूर्णः क्षीरिणा वाऽपि कुर्याच्चन्दनरेणुना ॥ (पा० प्र० चि० ७१/१७९, १८०)
४. नाभिपाके।शस्त्रोभिशोष्यवपुनतम्। दुग्धेन कृच्छागशकृता (दग्धेन छागशकृता-शु० पा०) त्वक्चूर्णः ॥ (पा० प्र० सद्गु) (यो० १० बालरोग० चि०)

असम्यक्कल्पनाशाम्भेः स्थादिनामो विवृम्भिका ॥ (अ० सं० ३० २/१०)

नाभि के असम्यक् उपकल्पन से आशाम-व्याघ्राम से उगुण्डित (लम्बाई एवं चौड़ाई से उठी हुई), पिण्डलिका (परिमण्डलयुत या गोल एवं कठिन), विनामिका (किनारे उठी हुई एवं मध्य में गिन्ने) तथा विवृम्भिका (बार बार बढ़ने वाली) आदि व्याधियों का भय रहता है।

महर्षि वाग्भट ने संक्षेप में लिखा है कि नाभि के ठीक से न काटने से विनाम एवं विवृम्भिका व्याधियाँ हो जाती है।

Due to improper cutting of umbilical cord following abnormalities of umbilicus of child may develop i.e. *utunūdiā* in *dyāma* and *vyāyāma* (protuberant in length and width or having broader base but less protuberance), *pinḍalika* (round and hard protuberance), *vināmika* (protuberant in edges and depressed in centre) or *vijimbhika* (having recurrence of protrusion).

आ) चिकित्सा (Treatment)

गुस्ता एवं लघुता (विकारोत्पन्नक वात एवं पित्त आदि दोषों की) का विचार करके अविदाही, वातपित्त-शामक अथवा, जलसादन, परिशेवन तथा सर्पि (वातपित्त शामक सर्पि का आप्यन्तर प्रयोग) के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात् अन्तः एवं बहिः दोनों प्रकार से वातपित्त-शामक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए।

Giving due consideration to *gurutā* (heaviness) and *laghutā* (lightness) of *vāta*, *pitta* etc. *doṣas*, specific massage, anointments and irrigations with *avidhī* (which do not produce burning sensation) drugs capable of suppressing *vāta* and *pitta* should be done. *Ghṛta* (treated with the drugs of above qualities) should be used internally and externally.

३) नाभितुण्डी-लक्षण एवं चिकित्सा (Clinical features and treatment of nābhituṇḍī)

वात से आश्रयित अर्थात् फूली हुई तथा पीड़ायुक्त नाभि को तुण्डी कहते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए वातहर स्नेह, स्वेदन तथा उपनाहन का प्रयोग करें।

The umbilicus inflated by *vāyu* and having pain is known as *nābhituṇḍī*.

Oleation, sudation and unction with the drugs capable of suppressing *vāta* should be done for its cure.

४) नाभिशोथ-चिकित्सा (Treatment of inflammation of umbilicus)

(१) मिट्टी के ढेले को अग्नि में तपाकर दूध में बुझाएँ, उसकी ऊष्मा से नाभि का स्वेदन करें। इससे नाभिशोथ

१.आयामो दैर्घ्यं, व्याघ्रामो विस्तराः। ताभ्यामुगुण्डिता आशामव्याघ्रामोऽगुण्डिता, दीर्घपीतलघुलेच्यर्धः, पिण्डलिका परिमण्डलयुताः, विनामिका अन्तोच्चूना मर्यादिनाः, विवृम्भिका तु मुहुर्मुहुर्दीर्घमती ॥ (च० सं० शा० ८/४५ की चक्र० टीका)

२. तत्राविदाहिभिर्वातपित्तशामकैर्मन्त्रोत्सादनपरिधैः सर्पिर्भिर्धोषक्रमेत गुस्ताश्रयमभिपसापीय ॥ (च० सं० शा० ८/४५)

३. वातपित्तहरं कर्म तत्रान्तर्दीर्घाचरेत् ॥ (अ० सं० ३० २/१०)

४. वतीनाभ्यापिनां नाभिं सरुजं गुण्डिसंशिताम्। मालतनैः प्रशमयेत् स्नेहस्वेदोपनाहैः ॥

(सु० सं० शा० १०/४३, ४४ एवं अ० सं० ३० २/८९)

का शमन हो जाता है^१।

Sudation should be done with the vapour obtained by dipping heated clod of earth in milk.

५) नाभि का समय पर पात न होने पर चिकित्सा (Treatment if umbilical cord does not fall off)

यदि (नाभि उपकल्पन के) पाँचवें दिन भी नाल का पात न हो तो जले हुए अक्षरों की ठण्डी राख का अवचूर्णन करें अथवा धूमि पर गाढ़े घिसे हुए गुड़ का लेप करें^२।

If the umbilical cord attached to the umbilicus does not fall off even after five days of birth then cooled ash of burnt charcoal should be sprinkled over it or else thick paste of jaggery prepared on the ground should be applied locally.

६) नालपातोपरान्त भी उन्नत रहने पर चिकित्सा (The treatment of protuberance or growth after detachment of umbilical cord)

नालपात हो जाने के बाद भी यदि उन्नत (उभरी हुई) रह जाए तो छान-शकृत को दाघ करके अवचूर्णन करना चाहिए^३।

If protuberance or growth after detachment of umbilical cord persists then burnt pellets of goat should be sprinkled over it.

७) नाभित्रण की चिकित्सा (Treatment of umbilical ulcer)

अनुकूल नाभि में (व्रण के) रोपण के लिए अश्वगन्धा, अज्रन, बकरी एवं भेड़ का शकृत तथा यशिमधुक के चूर्ण को घृत में मिलाकर लेप करना चाहिए^४।

For healing of umbilical wound powdered *aśwagandhā*, *ajjra*, pellets of goat and sheep and *yasāmadhuka* mixed with *ghṛta* should be applied.

विमर्श (Comments)

नाभिपाक, नाभिशोथ, नालपातन के बाद भी उन्नत रहना तथा नाभित्रण इन चारों स्थितियों के यद्यपि विशिष्ट लक्षणों का निर्देश नहीं दिया गया है, पर नाम के आधार पर नाभि का शोथ एवं पाक नाभिगत उपसर्ग की ही दो स्थितियाँ मानी जा सकती हैं। पुरोक्तवि के पूर्व नाभिशोथ एवं तत्तद्वात् पूरोक्तवि हो जाने पर नाभिपाक। कभी कभी रोपण की प्रक्रिया में विकार आने से किसी भी व्रण में अत्यधिक उष्ण (ओवरथ्रैन्थेसिस) बन जाता है, जो सम्भवतः नालपातन के बाद उष्णर के नाम से दिया गया है। नाभिगत व्रण सामान्य व्रण का वर्णन है। नाभि के असम्यक् उपकल्पन से उत्पन्न सभी व्याधियाँ व नाभितुण्डी विभिन्न प्रकार की नाभिगत आन्वृद्धि का वर्णन प्रतीत होती हैं। नाभितुण्डी में विद्यमान रुजा का स्पष्टीकरण कुछ कठिन है क्योंकि सामान्यतया अमररुद्ध आन्वृद्धि में रुजा नहीं होती, फिर भी कभी कभी उदर्याकर्णता

१. मुनिपण्डेनामिन्तरेण क्षीरसिक्तेन सोम्या। स्वेदरेदुष्वितां नाभिं शोथस्तेनोपशाम्यति ॥

(शा० प्र० वि० ७१/१७८ एवं यो० १० बा० १० वि०)

२. प्रदीपाङ्गारजसा प्रशातोऽवचूर्णयेत्। पञ्चमेऽहन्त्यतन्नालं लेपयेद्वा गुडाम्भसा ॥

सान्द्रेण धूमि घृष्टेन॥ (अ० सं० ३० २/८५)

३.नालपातोऽपि चोन्नतम्। नाभिं छापौन शकृता दाघेनात्तर्धचूर्णयेत् ॥ (अ० सं० ३० २/८६)

४. अश्वगन्धाज्जनाजित्विड्याटीमधुकादिभिः। रोपयेच्चूर्णितेनाभिं स्नेहयुक्तेनुरुताम् ॥ (अ० सं० ३० २/८७)

में छिंचाव होने से रूखा की अग्निसृति होती है। उपर्युक्त आधार पर संहिताओं में वर्णित विभिन्न व्याधियों का निम्न व्याधियों से समञ्जस्य किया जा सकता है—

नाभिशोथ	नाभि में शोथ
नाभिपाक	नाभि की पूयमयता
पतन के बाद उन्नता	अत्यधिक रोपणवस्तु बन जाना
नाभिघ्न	नाभि के पतनोपरान्त अग्रित घ्न
उज्जिह्वित, विजृम्भिक, विनामिका, नाभिगुण्डी	विभिन्न आकार की नाभिगत आन्त्रवृद्धि

Clinical features of above described disorders except *nabhigūḍī* have not been given; however, on the basis of their nomenclature, these can be equated with the diseases described to-day in following way—

<i>Nabhisōha</i>	Inflammation of umbilicus.
<i>Nabhipāka</i>	Suppuration of umbilical wound.
<i>Unnāḍ</i> after its <i>patana</i>	Over granulation tissue of umbilical wound.
<i>Nabhivṛana</i>	Umbilical ulcer.
<i>Uttundiā</i> , <i>Vijrmbhikā</i> , <i>Vināmikā</i> and <i>Nabhigūḍī</i>	Umbilical hernias.

उल्बक (Ulbaka)

अ) हेतु, सम्प्राप्ति एवं लक्षण (Etiopathogenesis and clinical features)

गर्भाशयसामग्र्यमनाच्छ्लेषणः कण्ठगतस्य वा । सम्पर्कादिद्वये दुष्टो मार्गानावृणुते रसः ॥
बन्धमुष्टिस्ततो मुखनौगैर्बालोऽभिभूयते । हृद्रोगक्षेमकश्चासकसच्छर्दिन्वादिभिः ॥

उल्बकं सहजं व्याधिमन्वृणुं च तं वेदेत् ॥ (अ० सं० उ० २/१९)

गर्भोदक का वजन न होने अथवा कण्ठगत स्लेष्मा का हृदय से सम्पर्क होने से दूषित हुआ रस मार्गों का (प्रणवह स्रोतस् का) अवरण कर लेता है। इससे बालक की मुट्टियाँ बँध जाती हैं, वह हृद्रोग, आक्षेपक, श्वास, कास, छर्दि तथा ज्वर आदि रोगों से पीड़ित हो जाता है। इस व्याधि को उल्बक, सहज या अमनुष्यव्याधि के नाम से कहा जाता है।

Due to improper emesis of *garbhodaka* (liquor amni) or contact of *ślesmā* situated in throat with the heart, the *rasa* gets vitiated and encircles or obstructs the *mārgas* (channels or *prāṇavaha srotasas*). Due to this the fists of the child get tightened and he suffers from *hṛdroga* (cardiac disorders), *ākṣepaka* (convulsions), *śwāsa* (dyspnoea), *kāsa* (cough) *chardi* (vomiting) and *jwara* (fever) etc. disorders. This disease is known as *ulbaka*, *sahaja* or *ambupūṇya vyādhi*.

विमर्श (Commens)

सामान्य बालक के कण्ठ में स्लेष्मा रहता है जो प्रसवोपरान्त मुखशोधन से स्वच्छ किया जाता है, यही स्लेष्मा या गर्भोदक यदि कण्ठ से नीचे हृदय की ओर अर्थात् फुफ्फुसों में पहुँच जाय तो चूषण-जन्य श्वसनक चक्र (एस्पैरेशन न्युमोनिया) हो जाता है। उल्बक नाम से सम्भवतः इसी व्याधि का वर्णन है।

Throat of new born is covered with mucus, which is cleaned immediately after delivery, however, some times this mucus and/or liquor amni is inhaled by the child which produce aspiration pneumonia. Probably *ulbaka* is description of this very aspiration pneumonia.

आ) चिकित्सा (Treatment)

१) प्रातःकाल (स्नान)पान के अनन्तरल में छागामूत्र का सेतोविशोधनार्थ पान करायें।

२) बालक को स्नान एवं अभ्यङ्ग न करायें।

३) निम्नलिखित घृत का पान करायें।

बिल्वामूल (बृहत् पञ्चमूल), बृहती तथा पञ्चकोल एक एक पल, धन्वमांस (जाङ्गल मांस) आठ पल तथा शशमूर्ध्न (खरगोश के सिर का मांस) आठ पल लेकर सोलह गुने जल के साथ आठ भाग (आधा) शेष रहने तक पकायें। क्वाथ के सम भाग बकरी का मूत्र, मदिरा, दीधे तथा क्षीर प्रत्येक मिलाकर उसमें विडङ्ग, सैन्धव, अजानी, चविका, देवदारु, हिला, हिङ्गु, लशुन तथा व्योष का चिकना पिसा एक-एक कर्ष कल्क डालकर एक प्रस्थ घृत पाक करें। इस घृत को पीने से सहज (उल्बक), जुल्म, हिष्मा, वातव्याधि तथा वातजन्य पाण्डुरोग नष्ट होते हैं। यह स्वस्थ बालक को भी पुष्टिदायक है।

i) In the morning inbetween breast feeding, goat's urine should be given orally for cleansing the *srotasas* (channels).

ii) Bath and massage should not be given.

iii) Following *ghṛta* should be given orally.

Bilvāmūla (*bṛhat pañcamūla*), *bṛhatī*, and *pañcakola* each one *pala*, meat of wild animals and head of rabbit each eight *palas* should be cooked with sixteen times water, when half remains, it should be filtered. Now in this decoction, goat's urine, wine, curd and milk each equal to the quantity of decoction should be mixed, besides finely pestled *viḍāṅga*, rock salt, *ajāyā*, *cavikā*, *devadārū*, *hingsā*, *hingū*, *lāśūna* and *vyoṣa* each one *karṣa* should also be mixed. With this mixture, one *prastha* *ghṛta* should be cooked with standard procedure. Use of this *ghṛta* cures *ulbaka*, *gulma*, *hidhma*, disorders of *vāta* and *vāyā pāṇḍu*. This also gives strength and nourishment even to a healthy child.

□

१. सेतोविशोधनं प्रातस्सिम्भन्तरपानकम् । विदव्याच्छगलं मूत्रं स्नानाभ्यङ्गौ च वर्जयेत् ॥

बिल्वामूलबृहतीपञ्चकोलं पलाशकम् । धन्वमांसपलान्यष्टौ शशमूर्ध्नः पलाष्टकम् ॥

साधयेत् षोडशगुणे सलिलेऽव्यंशशेषितम् ॥

तेन क्राशेन कवाशैर्दुदास्यं विपचयेत् । छागामूत्रमदिगाधक्षीरसमाश्रकम् ॥

विडङ्गसैन्धवजानीचविकादेवदारुभिः । सहिस्वाङ्गुललशुनैः सव्योषैः स्तक्ष्णकलिकनैः ॥

तत् पानाद्वाति सहजगुल्महिष्मातिलमथान् । पाण्डुरोगं च वातोत्पन्नं स्वस्थवृत्ते च पुष्टिदम् ॥ (अ० सं० उ० २/१२, १३)

अध्याय १९

CHAPTER XI

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

(STANYA OR BREAST MILK AND DHĀTRĪ OR WET NURSE)

स्तन्य-निर्माण (Formation of stanya or breast milk)

रसप्रसादो मधुः पक्वाहारतीमिति तवः । कृत्स्नदेहात् स्तनौ प्राप्ताः स्तन्यमिदमधीयते ॥

(सु० सं० ति० १०/१८)

पक्व आहार से उत्पन्न रस का मधुर प्रसाद भाग, सोरे शरीर से जाकर स्तनों को प्राप्त होकर स्तन्य कहा जाता है । टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि व्यन वायु के द्वारा रस धातु सोरे शरीर में पहुँचती है^१ (अतः स्तनों में भी जाती है) ।

आचार्य भावमिश्र तथा योगरत्नाकरकार ने भी महर्षि सुश्रुत सदृश ही अपने विचार व्यक्त किए हैं^२ ।

गर्भिणी-आहार के द्वारा गर्भपोषण का वर्णन करते समय महर्षि चरक एवं भेल ने स्पष्ट किया है कि गर्भिणी के आहार का एक अंश स्तन्य के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है^३, यद्यपि महर्षि काश्यप ने इस अंश को स्तन-पोषक माना है परन्तु स्तन पुष्ट होकर स्तन्य का ही निर्माण करेंगे ऐसा मान सकते हैं^४ ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी गर्भ-पोषण-वर्णन के अन्तर्गत माता के आहार रस से ही स्तन्य की उत्पत्ति मानी है एवं राज तथा स्तन्य दोनों को ही रस के प्रसाद के उत्पन्न माना है^५ । स्तन्य को रस धातु से निर्मित या रस धातु का उपधातु भी माना गया है^६ ।

यद्यपि उपर्युक्त सभी स्थानों में आचार्यों ने रस से ही स्तन्य की उत्पत्ति मानी है, परन्तु महर्षि काश्यप ने रक्तगुल्य

१. कृत्स्नदेहादित्यादि । रसधातोर्व्यानविश्वस्य सर्वदेहात्तात्वात् ॥ (सु० सं० ति० १०/१८ की डल्ह० टीका)

२. (अ) रसप्रसादो । कृत्स्नादेहात् । रसप्रसादः रसस्य सारः । (सु० सदृश)

(भा० प्र० पूर्व० ४/७ व टीका)

(आ) रसप्रसादो । (सु० सं० सदृश ही) (यो० २० क्षीरलोचनं)

३. च० सं० शा० ६/२३ (पृष्ठ १४४); भे० सं० शा० ५/७ (पृष्ठ १४६)

४. का० सं० सू० १८/६, ७ (पृष्ठ १४५)

५. (अ) रस एव च पयोभूतः ॥ (अ० सं० शा० २/३३)

(आ) स्त्रीणां रजसः । स्तन्य । उभयमपि चैतद्रसप्रसादान्तरमिति ॥ (अ० सं० शा० ५/१८)

६. (अ) रसात् स्तन्यं रसात् स्तन्यं प्रसादवत् । (च० सं० वि० १५/१७ की चक्र० टीका)

(आ) रसात् स्तन्यमर्तव्यं च । (सु० सं० सू० १४/१० की डल्ह० टीका)

(३) चरितानां प्रसूतानां धमनीषां स्तनौ गतात् । रसादेव हि जायते स्तन्यं स्तनयुगाशयम् ॥ २१० ॥

स्तन्यं । क्रमात् सतोपघातवः ॥ २११ ॥ (भा० प्र० पूर्व० ३/२१०, २११)

(ई) स्तन्यं सतोपघातवः ॥ (शा० सं० पूर्व० ५/१६, १७) (पृष्ठ ५३)

के वर्णन के अन्तर्गत रक्त से भी स्तन्य की उत्पत्ति मानी है; महर्षि वाग्भट एवं टीकाकार डल्हण ने असा-निर्माण-वर्णन में यही विचार व्यक्त किए हैं कि यही रक्त स्तनों में जाकर कफ के द्वारा उत्पन्न हो, स्तन्यता को प्राप्त होकर प्रसूता में पुनः आहार रस से वर्धित होता है ।

महर्षि हरित ने क्षीरोत्पत्ति, स्तन्य की रश्तेवर्णना एवं कन्याओं तथा वन्ध्याओं में इसकी अनुपस्थिति आदि का वर्णन करते हुए लिखा है कि जो जो आहार (स्त्री द्वारा प्रयुक्त दूध, जल, भक्ष्य पदार्थ) लिया जाता है वह उस स्थित शिरा (अन्नप्रणाली) अथवा क्षीरवाही शिराओं का अनुगमन करता हुआ, पित्त से संयुक्त होकर जठर में पहुँच, वहाँ की अग्नि से पचित हो, पुनः पित्त से मूर्छित (धात्वन्तर्गत पचित) होकर एवं पच्यमान होकर, शिराओं (स्तन्यवाही शिराओं) को प्राप्त हो क्षरण करता है अर्थात् बाहर निकलता है, यह अग्निसेनात्मक पदार्थ क्षीर कहलाता है । जिस प्रकार पित्त के द्वारा पक्वता को प्राप्त होकर रक्त (पूय में परिणत होकर) रश्तेत्व को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार पित्त के संयोग से क्षीर रश्ते हो जाता है । क्षीर स्निग्ध एवं रश्ते होता है^१ ।

कन्याओं में धातुओं के अल्प बल होने तथा वन्ध्याओं की क्षीरनाडियों के बल से परिपूरित होने के कारण क्षीर की उत्पत्ति नहीं होती ।

महर्षि भेल ने स्तन्य का प्राणायतनों में समावेश किया है^२ ।

After digestion of food the *rasa* is formed. Sweet essence part of this *rasa* circulating through entire body by the action of *vyāna vāyu* reaches breasts and is termed as *stanya* (breast milk) or in other words the *stanya* is formed from *rasa*. It is also *upadhānu* of *rasa*, though Kāśyapa, Vāgbhata I and Dhaṇya accept the formation of *stanya* from *rasa*, however, while describing *raktaguṇma* or placenta formation they have mentioned that one part of *rakta* or the *rakta* left over after formation of placenta reaches breasts, gets coloured by *kapha* and forms *stanya*, after delivery it is increased or formed from *rasa*. *Raja* (menstrual blood) and *stanya* both are said to be derived from essence part of *rasa*.

१. (अ) शोणितम् । ॥ ११ ॥

..... किञ्चित् स्तन्याय कल्पते ॥ २० ॥ तथैव गर्भः सूतायाः सद्यः स्तन्याय कल्पते ॥ २१ ॥

(का० छि० १/१९, २०, २१)

(आ) जलपुशेर्ष चोर्ध्वमसृक् प्रतिपद्यते । । स्तनाश्रयमेव च कफोपरश्चितं स्तन्यतामुपगतं प्रसूतायाः पुनराहारसे-
नान्यायते ॥ (अ० सं० शा० २/११, १२ तथा सु० सं० शा० ४/२४ की डल्ह० टीका-कलकता प्र०)

२. यद्यदाहारजान्तु रसं क्षीरशिरानुगम् । (यद्यदाहारसञ्जातं उरिस्थतशिरानुगम्-पाठ-भेद) ।

सरोजलं च भुक् च ('सं' जलं तथा 'जलद' जलमायाति' दो पाठ-भेद) तथा पित्तेन संयुतम् ॥ २ ॥

पाचितं जायते चक्रे पित्तेन सह मूर्च्छितम् । पच्यमानं शिराप्रतं क्षीरलोचनं (क्षरते येन-पाठभेद) पुनरक । ॥ ३ ॥

तेन क्षीरमतिष्ठतमग्निसामान्तकं (सोमान्तक-पाठ भेद) पयः ॥ ४ ॥

क्षीरं स्निग्धं तथा रक्तं पित्तेन पाकतां (शु० पा० पक्वतां) गतम् । रक्तं श्वेतत्वमायाति तथा क्षीरं सिद्धं भवेत् ॥ ८ ॥

क्षीरानाडी कुमारीणां वन्ध्यानां च कथं भवेत् । अल्प धातुबलं यस्मात्समात् क्षीरं न जायते ॥ ९ ॥

वन्ध्यानां क्षीरानाड्यस्तु वातेन परिपूरिताः । क्षीरं च न भवेत्तस्मात् ॥ १० ॥ (हो० सं० प्रथ० स्या० ८)

(पाठभेद एली राजन द्वारा इन्स्टिट्यूट फ्रांसेस डे इण्डोलॉजि पाण्डुबेरी से १९७४ में प्रकाशित 'हारीत संहिता' के पृष्ठ ८६ एवं २४३ से उद्धृत)

३. स्त्रियाः स्तन्येन । इत्येपरिदर्शभिः प्राणः ॥ (भे० सं० सू० १७/२)

Hārta says that what-so-ever is ingested by the woman, same travelling through the *śīrās* of chest (esophagus) or milk-carrying *śīrās* and getting mixed with *pīta* reaches *jāhara* (stomach). There it gets metabolised by digestive fire and then again getting processed and metabolised by *pīta*, reaches *śīrās* or breasts and is ultimately discharged. This secretion having association of *agni* and *soma* is known as milk. As the blood due to action of *pīta* gets suppurated and becomes white, so is the case with milk. In young girls due to less strength of *dhatūs* and in infertile women due to filling of milk-carrying channels by *vāyu*, the milk is not formed.

Bhela has included milk amongst ten *pāṇḍyātanas* (seats of life).

विमर्श (Comments)

सामान्य दृष्ट्या उपर्युक्त वर्णन में आचार्यों के स्वयं के मत में ही विशेषाभास सा लगता है क्योंकि रक्त एवं रस दोनों से ही स्तन्य की उत्पत्ति वर्णित की है। परन्तु थोड़ा विचार करने पर विषय सुस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि रक्त से स्तन्य-निर्माण गर्भावस्था के काल में वर्णित है। गर्भावस्था में स्तन्य का निर्माण करने वाली ग्रन्थियाँ, स्तन्यवाही नलिकाओं आदि का नवनिर्माण, पोषण एवं वर्धन आदि प्रक्रियाएँ होती हैं जिनके लिए रक्त अत्यावश्यक है। पोषणादि प्रक्रियाएँ गर्भावस्था के ही काल में परिपूर्ण हो प्रथम स्तन्य या कॅलॉस्ट्रम का भी निर्माण हो जाता है, जिसके निर्माण में भी रक्त का योगदान है। प्रसव के पश्चात् केवल स्तन्य-निर्माण का कार्य होता है जो रस के द्वारा सम्पादित होता है।

Though apparently it looks that there is difference of opinion regarding formation of *stanya*, because it is described to be formed from *rakta* or *rasa* both. However, careful scrutiny clarifies it. Formation of *stanya* from *rakta* is described during pregnancy period. During pregnancy new lactic glands and lactiferous tubules are formed, existent ones grow and develop. For this growth and development during pregnancy period the *rakta* (blood) is essential, first milk secretion or colostrum is also formed during pregnancy from *rakta*. After delivery there is no further growth of lactic glands, but their function i.e. formation of milk is increased, which is accomplished by *rasa*.

स्तन्य-प्रवृत्ति-हेतु (Cause of *stanya pravṛtti* or milk ejection)

आहारसंयोजित्वादेवं स्तन्यमपि त्रिविधः ॥ २१॥

तदेवाप्तसंभारं दर्शनात् सरणादपि। ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् सम्प्रवर्तते ॥ २२॥

स्नेहो भिन्नस्तस्य प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ (सु० सं० नि० १०/२१ से २३)

धमनीनां हृदिस्थानां विवृतत्वादनन्तरम्। चतुरात्रात् विरात्राद् वा स्त्रीणां स्तन्यं प्रवर्तते ॥ (सु० सं० शा० १०/१४)

सिराणां हृदयस्थानां विवृतत्वाद् प्रसूतिः। तृतीयेऽह्नि चतुर्थे वा स्त्रीणां स्तन्यं प्रवर्तते ॥

(अ० सं० उ० १/११ एवं अ० ह० उ० १/११, १२)

महर्षि सुश्रुत ने सर्वशरीर स्थित शुक्र के स्त्री के दर्शनादि से प्रसवण के साथ स्तन्य का सामञ्जस्य स्थापित करते हुए लिखा है कि आहार-रस से उत्पन्न होने के कारण स्त्रियों का स्तन्य भी अपत्य के स्पर्श, दर्शन, स्मरण तथा शरीर के सम्पर्क से शुक्र-सदृश ही प्रवर्तित होता है। परन्तु इन सभी (स्पर्शादि चारों) में भिन्न स्नेह (बन्धे के प्रति वात्सल्य एवं स्त्री के प्रति काम) ही प्रधान रूप से प्रवृत्ति का कारण होता है।

पुनःश्च लिखा है कि बाद में (प्रसव के अनन्तर) हृदय-प्रदेश में स्थित धमनियों के विवृत हो जाने से तीन या चार रात्रि के पश्चात् स्त्रियों में स्तन्य की प्रवृत्ति होती है।

अष्टाङ्गसंग्रहकार तथा अ० हृदयकार ने धमनी के स्थान में सिरा को उल्लेख किया है कि प्रसव के पश्चात् हृदयस्थ सिराओं के विवृत होने से तीन या चार रात्रि के पश्चात् स्त्रियों में स्तन्य की प्रवृत्ति होती है।

महर्षि कारणप ने रक्तगुल्म अध्याय में स्तन्य-प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए बालक के प्रति माता के प्रेम को ही मुख्य कारण माना है^१।

महर्षि हारीत ने लिखा है कि स्त्रियों में प्रसव (बालक का जन्म) बल के साथ (अति प्रवाहण के लिए प्रयुक्त बल के साथ सम्पन्न) होता है जिसके कारण स्रोतों की विद्युद्धि होती है एवं क्षीर तत्काल प्रवर्तित हो जाता है। जिससे (तत्काल प्रवर्तन के कारण) सद्यःप्रसूता स्त्रियों का दुग्ध स्तैषिक या कफ-प्राधान्य वाला होता है, तथा (कफ की प्रधानता के कारण) दुग्ध में कठिन्ता (गाढ़ापन) आ जाती है अतः इसका परित्याग करना चाहिए अर्थात् बन्धे को नहीं देना चाहिए^२।

माधवदिनकार ने महर्षि सुश्रुत के ही वर्णन को उद्धृत कर दिया है^३। भावप्रकाश में भी शब्दान्तर से यही वर्णन है^४।

As semen is ejaculated by thought, sight or touch of the woman or coitus with her, similarly milk is also ejected by thought, sight or touch of the child and also with his physical contact (suckling). For proper flow of milk uninterrupted affection for the child is mainly responsible.

After delivery on third or fourth day the *dhamanīs* or *śīrās* situated in cardiac region get dilated and initiate milk ejection.

Hārta says that due to force used during bearing-down efforts by the parturient woman, her *śrotasas* get cleared leading to sudden milk ejection, however, this milk is thick due to dominance of *kapha*, hence should be discarded.

विमर्श (Comments)

सद्यःप्रसूता स्त्री के स्तन्य अर्थात् कॅलॉस्ट्रम में सामान्य स्तन्य की अपेक्षा प्रोपूजिन एवं लवण की मात्रा अधिक तथा शर्करा एवं वसा की मात्रा कम होती है, इन गुणों के ही कारण सम्भवतः महर्षि हारीत ने इसका पान निषिद्ध किया हो, यह प्रथा आधुनिक काल में भी प्रचलित थी, परन्तु कॅलॉस्ट्रम में प्रतिरक्षी घटक (एन्टिबॉडी) एवं महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की उपस्थिति के ज्ञान के उपरान्त इसका प्रयोग लाभदायक माना जाने लगा है।

The first milk or colostrum is rich in protein and salt and deficient in sugar and fat

१. का० सं० खिल० १/४५। (पृष्ठ ३१८)

२. प्रसूतासु च नारीषु बलेन सह सूयते। तेन स्रोतो विद्युद्धिः स्यात् क्षीरमासु प्रवर्तते ॥ तस्मात् सद्यः प्रसूतायां जायते स्तैषिकं पयः। तेन कठिन्तां याति तस्मात् परित्यजेत्।

(ह० सं० प्रथ० स्या० ८/११, १२)

३. आहारसंयोजित्वाद् प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ (सु० सं० सदृश) (मा० नि० ६/१३, ४)

४. स्तन्यं त्रिरात्रावशीर्षां वा चतुरात्रादनन्तरम्। प्रवर्तयन्ति विवृता धमन्यो हृदये स्थिताः ॥

पयः पुत्रस्य संभारदर्शनात्समन्वितम्। ग्रहणादप्युपेत्य शुक्रवत्सम्प्रवर्तते ॥ स्नेहो भिन्नस्तस्य प्रवाहे हेतुरुच्यते ॥ (मा० प्र० पूर्व० ४/८ एवं ९)

contents in comparison to normal breast milk, probably due to these qualitative changes its use was contraindicated by Hārīta, this practice was prevalent even in 20th century, however, after the knowledge of presence of good amount of antibodies and essential nutrients in this colostrum, its use is being considered beneficial.

स्तन्य का प्रमाण (Amount of stanya)

स्तन्यस्य द्वौ (अञ्जलतयः) । (अ० सं० शा० ५/९८)
द्वौ चञ्चली तु स्तन्यस्य ॥ (अ० इ० शा० ३/८१)

स्तन्य का प्रमाण दो अञ्जली होता है ।

Amount of milk is two *anjālī*.

विमर्श (Comments)

स्तन्य की मात्रा में अत्यधिक वैभिन्न्य मिलता है तथा उपर्युक्त मात्रा को सम्पूर्ण मात्रा मानना भी उचित नहीं होगा, परन्तु इसे सामान्य स्वास्थ्य की स्त्री में स्तनों से एक बार में निकलने वाले स्तन्य की मात्रा मान सकते हैं ।

Total amount of milk varies greatly in different individuals, the quantity mentioned above can not be considered as total quantity, however, two *anjālī* amount may be considered as the amount normally excreted by a healthy woman at one sitting.

धत्री (Dhātṛī or wetnurse)

मातृ-स्तन्य के समकक्ष अन्य दूध न होने के कारण माता की दैहिक या मानसिक व्याधियों की उपस्थिति में उसके द्वारा स्तन-पान न कराए जा सकने पर प्राचीन-काल में धात्री द्वारा स्तन-पान कराने की व्यवस्था का वर्णन है । वाग्भट ने स्पष्ट लिखा है कि माता के स्तन्य के समकक्ष देहवृद्धिकाक अन्य कोई भी स्तन्य नहीं है अतः उसके अभाव में स्तन-युक्त दो धात्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए^१ । अन्य सभी आचार्यों ने भी धात्री-व्यवस्था का वर्णन तो दिया है पर उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया । धात्री-व्यवस्था-वर्णन का एक यह भी कारण हो सकता है कि उस काल में सीङितायें अधिकालतः राजाओं के आश्रित विद्वानों द्वारा लिखी जाती थीं, बालकों की सभी व्यवस्था कुमार या राजकुमार को ही ध्यान में रखकर वर्णित प्रतीत होती है । साम्राजियों द्वारा सौन्दर्य-ह्रास के भय से स्तनपान न कराए जा सकने के कारण धात्री-व्यवस्था की गई हो ।

सभी आचार्यों ने धात्री की विशिष्ट परीक्षा-विधि का वर्णन किया है जिस परीक्षण के उपरान्त ही उसे स्तन-पान कराने के लिए रखा जाता था ।

As no other milk can be compared with mother's milk for proper growth and development of the child, so in the conditions of inability for feeding the child by the mother due to her physical or psychological disorders, alternative arrangement for a wet-nurse has been advised in *āyurvedika* classics. Vāgbhaṭa II has advised arrangement of two wet-nurses, while other authors have not specified the number. Another reason for detailed description of wet-nurse could be that during the era of these *āyurvedika* texts the authors used to live under the patronage of rulers, all the texts were written under monarchism. Entire management of child is described considering the children of kings or *kumārās*. Probably, the

१. मातृव्य पिबेस्तन्यं ततरे देहवृद्धये । स्तन्यधात्र्यावसुषे कार्ये ॥ (अ० इ० उ० १/१५)

queens might not be preferring breast-feeding, lest their beauty is lost, naturally the wetnurse was arranged.

Specific qualities of the wet-nurse have been described or in other words thorough assessment of physical and psychological status of wet-nurse was done before her appointment.

धात्री-परीक्षा (Dhātṛī-parīkṣā or examination of wet-nurse)

अतो धात्रीपरीक्षामुपदेक्ष्यामः । अथ ब्रूयात्-धात्रीमानस्य समानवर्णा यौवनस्थां निभूतामातुरामव्यङ्गापव्य-सनामविरूपायुग्मिस्तां देशजातीयामक्षुद्रामक्षुद्रकर्मिणीं कुले जातां वत्सलामपोगां जीवद्वत्सां पुंवत्सां दोग्ध्रीमप्रमत्तामनुच्छाशायिनीमनन्त्यावसायिनीं कुशलपेचायां शुचिमशुचिद्वेषिणीं स्तनस्तन्यसंपदुलेतामिति ॥

(च० सं० शा० ८/५२)

ततो यथावर्णं धात्रीमुपयानमध्यमप्रमाणां मध्यमवयस्कामपोगां शीलवतीम् अचपलामरतोलुपामकृशामस्थूलां प्रसवक्षीरामलम्बोष्ठीमलम्बोद्वत्सलीमव्यङ्गामव्यसनिनीं जीवद्वत्सां दोषधीं वत्सलामक्षुद्रकर्मिणीं कुले जातमातो भूयिष्ठैश्च गुणैरन्वितां श्यामापारोपयबलवृद्धये बालस्य ॥ (सु० सं० शा० १०/२५)

अथास्य समानवर्णां मध्यमवयः शुचिरतोलुपा निभूतानातुरा जीवद्वत्सा वत्सला दक्षिणा ब्रह्मचारिव्यङ्गा बह्वक्षीरा शुक्लावग्राचारा दीर्घहृत्वादिदेहोषाष्टकहित्वा अलम्बोव्यञ्चचुक्रातिपीनहीनस्तनदोषमुक्ता युक्तचूचुका धात्री स्यातस्या एवं स्तन्यं पिबेत् । (अ० सं० उ० १/२०)

स्तन्यधात्र्यावुभेकार्ये तदसमादि वत्सले ॥ १५ ॥

अव्यङ्गे ब्रह्मचारिण्यौ वर्णप्रकृतितः समे । नीरुजे मध्यवयसौ जीवद्वत्से न तोलुपे ॥ १६ ॥
हित्वाहारविहारेण यत्नादुपचरेच्च ते ॥ (अ० इ० उ० १/१५ से १७)

तस्मात् संशोधनपरा नित्यं धात्री प्रशस्यते ॥ (का० सं० सू० ११/४)

समानसत्त्वा बालानां तस्माद्धात्री प्रशस्यते । उद्देगीवज्रासकरी विपरीता न शस्यते ॥

न जीवन्त्यथ जीवन्ति कृच्छ्रा धात्रीविषयधे । समानसत्त्वा बालानां पुष्टिगुणवर्तलं सुखम् ॥

(का० सं० सू० २८/३३, ३४)

अब धात्री-परीक्षा का उपदेश किया जा रहा है । धात्री को लगने के लिए (चैव) कहे । धात्री समान वर्ण की (बालक के ब्राह्मणादि वर्ण के अनुरूप), युवती (बाला या वृद्धा का असम्पूर्ण या क्षीण-धातु की होने के कारण परित्याग करना चाहिए), विनीत या शांत स्वभाव की, आतुरता रहित, अव्यङ्ग (हीनाधिकान्ग-विरहित), व्यसन रहित (किस्सी मादक वस्तु का व्यसन न करने वाली), विरूपा राहित (सुन्दर), जुगुप्सा रहित, देश एवं जाति में समान, क्षुद्रता रहित, क्षुद्रकर्म न करने वाली (जैसे विचार एवं कर्तव्य वाली), (उत्तम) कुल में उत्पन्न, वत्सला (पुत्र को प्रेम करने वाली), अयोग अर्थात् स्वस्थ, जीवित सन्तान एवं पुमान् पुत्र वाली, प्रचुर मात्रा के दूध वाली, अप्रमत्त (बहुत ही सावधानी से कार्य करने वाली), बालक के मल-मूत्रादि के ऊपर शयन न करने वाली (अर्थात् उन्हें तत्काल ही साफ करने वाली), नीच कुल में न ब्याही गई हुई, उपचा-कुशल, पवित्र या स्वच्छ, अपवित्रता या अप्रच्छन्ना से द्वेष करने वाली तथा स्तन एवं स्तन्य के सम्पर्क से युक्त उत्तम होती है ।

महर्षि सुश्रुत ने शब्दान्तर से उपर्युक्त आशय का ही वर्णन करते हुए लिखा है, कि तदनन्तर वर्ण के अनुसार, मध्यम शरीर-प्रमाण की (न बहुत लम्बी, न नाटी), मध्यम वयस्का, योग रहित, शीलवती, चञ्चलता रहित (शांत स्वभाव वाली),

१. यौवनस्थामित्यनेन बालावृद्धोरसम्पूर्णक्षीणधातुत्वेन तयोर्निरासं करोति ॥ (च० सं० शा० ८/५२ की चक्र० टीका)

अलोलुप (लालची न हो), न बहुत पतली न बहुत मोटी, प्रसन्न शीर (त्रिकार रहित दुग्ध) से युक्त, जिसके होठ बहुत लम्बे एवं स्तन बहुत लम्बे अथवा बहुत उर्ध्व (छोटे) न हों, अव्यङ्ग, अव्यसना, जीवित वत्सा, प्रसू दुग्ध वाली, वासस्त्य करने वाली, क्षुद्र कर्म न करने वाली, उत्तम कुलोत्पन्न, अनेक उत्तम गुणों से युक्त तथा रगामा (रगामा निस्त्र्यं अधिकांशतः अधिक दुग्धवाली होती है) धात्री को बालक के आशय तथा बल की वृद्धि के लिए नियुक्त करें।

अष्टाङ्गसंहकार ने लिखा है कि धात्री समान वर्ण एवं मध्यम आयु की (क्योंकि तरुणी स्त्री अवस्तला एवं वृद्धा क्लेश सहने में असमर्थ होती है, वृद्धा का सन्त्य भी पुष्टिकर नहीं होता), पवित्र, अलोलुप, विनीत या शान्त, निरोग, जीवित वत्सा, चतुर या अनुकूल, ब्रह्मचारिणी, अव्यङ्गा, प्रचुदुग्धा, श्वेत (स्वच्छ) वस्त्र पहनने तथा शुद्ध विचारों वाली, दीर्घ, ह्रस्व आदि शरीर के आठ दोषों (अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति श्वेत, अति कृष्ण, अति लोम, अलौम, अति स्थूल एवं अति कृश) से रहित, अत्यधिक लम्बे या अधिक ऊँचे आदि दोषों से रहित चतुर्बुक् तथा अति पीन एवं हैन दोषों से युक्त स्तन एवं युक्त चतुर्बुक् (सुदृढ़ एवं सामान्य) वाली होनी चाहिए। उसका सन्त्य बच्चे को पीने को दें। अन्यत्र पारिगर्भिक होने के पक्ष के कारण गर्भिणी स्त्री के द्वारा स्तनपान का निषेध किया है।^१

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि वासस्त्य करने वाली, अव्यङ्ग, ब्रह्मचारिणी, वर्ण एवं प्रकृति में समान, निरोग, मध्यम वयस्का, जीवित वत्सा तथा अलोलुप धात्री हित आहार-विहार के द्वारा यत्नपूर्वक बालक का उपचार करती है।

महर्षि कारश्यप ने अति संक्षिप्त वर्णन किया है कि नित्य संशोधन से युक्त (शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारीक तीनों दोषों से रहित) धात्री उत्तम होती है। पुनश्च सत्त्व का प्राधान्य वर्णन करते हुए लिखा है कि बालक के समान सत्त्व वाली धात्री (यदि बालक सात्त्विक प्रकृति का है तो सात्त्विक प्रकृति की, यदि राजसिक प्रकृति का है तो राजसिक प्रकृति की धात्री आदि) प्रशस्त मानी गई है। विपरीत गुण वाली धात्री उद्वेग तथा विनासकारी होने से प्रशस्त नहीं है। विपरीत सत्त्व वाली धात्री होने से या तो बालक जीवित ही नहीं रहता या यदि जीवित रहता है तो अति कष्ट से। समान सत्त्व वाली धात्री बालकों को पुष्टि, आयु, बल एवं सुख देने वाली होती है।

यद्यपि महर्षि हारीत ने धात्री का विशिष्ट वर्णन नहीं दिया परन्तु शीर वर्णन में स्त्री के शरीर के वर्ण का प्राभाव मानते हुए कृष्ण एवं पीत वर्ण की स्त्री को ही श्रेष्ठ दुग्ध वाली कहा है। वर्णन इस प्रकार है—कृष्ण वर्णा स्त्री (स्त्री का दुग्ध) वृष्य तथा वातन्य होती है अतः इसका सन्त्य अच्छा होता है। श्वेत वर्ण की स्त्री का दुग्ध श्लेष्मकारक, रक्त वर्ण की स्त्री का दुग्ध वातकारक होता है। पीत वर्ण की स्त्री का दुग्ध पित्तशामक होता है और यह अच्छा है।^२

आचार्य भावमिश्र ने बालक के पालन के लिए भलीभाँति विचार कर ही धात्री के रखने का उपदेश देते हुए उपर्युक्त वर्णित गुणों के साथ स्वाधीन, अल्पदुग्ध, कपटरहित आदि गुणों का उल्लेख करते हुए निषिद्ध धात्री का पृथक् विस्तृत उल्लेख किया है कि शोकाकुल, क्षुधित, श्रान्त, सदा व्याधियुक्त, अल्पन्न, ऊँची (लम्बी), अल्पन्न नीची (नाटी), अति स्थूल, अति कृश, गर्भिणी, च्चर-पीडित, लम्बोजात स्तन वाली, अजीर्णकारक वस्तुओं का भोजन करने वाली, पय्य विरहित या

१. रगामा हि प्रायशः प्रचुरशीरा भवति । (सु० सं० शा० १०/२५ की डल्ह० टीका)

२. तरुणीत्यावस्तला । क्लेशे न सहते वृद्धा सन्त्यं वास्या न पुष्टिकृति । दक्षिणा अनुकूल । अर्थादेर्दशः अतिदीर्घत्वमहिस्त्वचमर्तिलोमत्वमलौमत्वमतिशुक्लत्वमतिकृष्णत्वमतिकारममतिस्थूलत्व च ।

(अ० सं० उ० १/२० की इन्द्र टीका)

३. न गर्भिण्याः भिन्ने सन्त्यं पारिगर्भिककृद्धि तत् ॥ (अ० सं० उ० १/३८)

४. कृष्णा वृष्णा च वातशी, पयस्तस्या विशेष्यते । श्लेष्मपयः श्लेष्मकृष्ण वातलं रक्तिकापयः । पित्तसंशमना पीता तस्याः शीरं विशेष्यते ॥ (हो० सं० प्रथ० ८/१४, १५)

कुपथ्य सेविनी, क्षुद्र कार्यों में अस्मिक वाली, दुःख से पीडित, चञ्चल (स्वभाव वाली) धात्री के स्तनपान करने से बालक व्याधियों से पीडित हो जाता है।^१

Caraka says that the wet-nurse should be identical in *varṇa* (similar in the caste i.e. for *brāhmanya* child the *brāhmanya* wet-nurse etc.), young (very young or old woman should be discarded due to presence of incomplete or decreased *dhatūs* respectively), humble or modest, free from impatience, not possessing deficient or accessory body parts, non-addict, beautiful, free from disgust, similar in *deśa* (living place) and *jāti* (sub-caste), neither mean-minded nor indulging in mean acts, born in high family, affectionate to the child, free from diseases, having alive male child and good amount of breast-milk, over cautious, not habituated of sleeping over excrements or used to clean the feces etc. immediately, not married in low cast, expert in nursing, pious, clean and having hatred from unpiousness or uncleanness and possessing good quality of breasts and milk.

Sūśruta giving almost similar description says that the wet-nurse should be of average height, middle-aged, free from diseases, well-behaved or urbane, free from fickleness, non-greedy, neither too thin nor too obese, possessing milk of good quality, not having too long or protuberant lips, having neither too short nor too long breasts and other non-addiction etc. qualities described by Caraka. The wet-nurse should be *śyāma* (dark complexioned) because the women of this complexion possess profuse milk. The wet-nurse is to be appointed for betterment of health, growth, development and strength of the child.

Vāgbhaṭa I agreeing with above description adds that wet-nurse should be clever, chaste or celibate, wear clean garments and keep pious ideas. She should be free from eight (i.e. too tall or too short in height, over fair or very dark in complexion, having excessive body hair or their total absence, obese or lean and thin) physical disorders. Her tears should be strong but neither too high nor too low. The breast milk of pregnant woman is contra-indicated because it causes *pāṇīgarbhika* disorder. Indu has clarified that middle aged woman is to be preferred because young woman does not have affection for the child and old woman can not withstand troubles as well as her milk also is not nutritious to the child.

Vāgbhaṭa II has given similar but very short description.

Kāḍyapa says that wet-nurse should use daily purifying measures (internal and external, physical and psychological). Wet-nurse belonging to similar *satva* (*śāntika*, *rājāsika* etc. *mānāsika prakṛtis*) to which child belongs is praiseworthy. Belonging to opposite *satva* is forbidden, because she will produce uneasiness and troubles to the child, thus the child will either not survive or survive with great difficulty. The wet-nurse of identical *satva*

१. पीताय यदि बालस्य विद्वद्वादुष्मातरम् । सुविचार्य गुणादोषाङ्गुयाद्धर्मो तदेदृशीम् ॥ २४॥

सर्वर्णं मध्यवयसं सञ्जीतं मुदितं सदा । शुद्धदुग्धं बहुशीरं सक्तामतिवस्तलम् ॥ २५॥

स्वाधीनामत्सन्तुष्टा कुलीनं सज्जानाम् । कैतवेन परित्यक्ता निवपुत्रसदृशं शिष्यौ ॥ २६॥

शोकाकुलाक्षुधाली च श्रान्ताव्याधिमती सदा । अल्पन्ना निरती नीचा स्थूलातीव पुरा कृशा ॥ २७॥

गर्भिणी च्चरिणी चापि लम्बोजातपयोधरा । अजीर्णबीजिनी चापि तथा पय्यविवर्जिता ॥ २८॥

असक्ता क्षुद्रकार्येषु दुःखार्ता चञ्चलाऽपि च । एतासां स्तनपानेन शिशुर्भवेति सामयः ॥ २९॥

(भा० प्र० पूर्व० ४/२४ से २९)

gives nourishment (*pusti*), longevity (*āyur*), strength (*bala*) and pleasure (*sukha*) to the child.

Hārīta has not described wet-nurse, however, describing effect of body-complexion of mother over her breast-milk says that the milk of woman having dark complexion is *vyaya* (aphrodisiac/anabolic) and pacifies *vāta*, thus its use is beneficial. Milk of whitish or reddish complexioned women vitates *śīrṣā* and *vāta* respectively, the breast milk of the woman having yellowish complexion pacifies *pitta*, thus, its use is beneficial.

Bhāvaprakāśa has advised to give due consideration to her ability to nurse the child at the time of appointment of a wet-nurse, besides above qualities, he has added the habit of independence, getting contented easily and non-insidious. Besides, obesity etc. disqualifications described above, the one who is stricken with grief, is hungry, tired, always disordered, pregnant, afflicted with fever and consumes diet which produces indigestion or non-congenial diet and is miserable, should also not be appointed. Lactation by the wet-nurse possessing above disqualifications produces diseases in the child.

स्तनसम्पत् (Stanasampat or merits of breasts)

यद्यपि धात्री-वर्णन के अन्तर्गत सभी आचार्यों ने सामान्य स्तनों वाली धात्री को श्रेष्ठ तथा अधिक लम्बे आदि स्तनों वाली धात्री को निषिद्ध बताया है, परन्तु महर्षि चक्र ने विषय को स्पष्ट करने के लिए इसका पृथक् रूप से भी वर्णन दिया है।

तत्रेयं स्तनसंपत्-नात्यूर्ध्वी नातिलम्बावतः कृशावतः पीनी युक्तीपपलकौ सुखप्रपानौ चेति (स्तनसंपत्) ॥

(च० शा० ८/१३)

यहाँ यह उक्त स्तन का वर्णन है-स्तन अधिक ऊर्ध्व (छोटे), लम्बे, कृशा (बहुत ही पतले या वसा-रहित) एवं मोटे न हों। उचित रूप के स्तन-चूड़क वाले, एवं सुख पूर्वक पिये जा सकने वाले (ऐसे चूड़क एवं स्तन जिनसे बालक सुख पूर्वक स्तन पान कर सके) स्तनों को श्रेष्ठ स्तन कहा गया है।

While describing the examination of wet-nurse, the qualities of breasts have already been included, however, to make the subject more explicit, Caraka has described following types of breasts as perfect ones.

The breasts should not be *atī ūrdhwa* (too much erect or upwards), *atī lamba* (too long or over dangling) *atī pīna* (excessive corpulent), *atī kṛśa* (too emaciated) and should have appropriate nipple. The breasts which are comfortable for sucking are said to be the best or perfect ones.

असम्पत् स्तनजन्य दोष (Abnormalities due to feeding with imperfect breasts)

तत्रोर्वस्तनी कालं कुर्यात् । लम्बस्तनी नासिकामुखं छादयित्वा मरणमापादयेत् ॥

(सु० सं० शा० १०/२५)

पीनोऽतिक्रमस्तस्य कुर्यादूर्ध्वोक्षमूर्ध्वीः । उच्छ्वासोद्यान्तबोऽतिसनोर्बोवितसंशयम् ॥

(अ० सं० उ० ३० १/३८)

ऊर्ध्व स्तन वाली स्त्री बालक को काल (विषय या भयानक) कर देती है तथा लम्ब स्तनी (बालक के) नासिका एवं मुख का आच्छादन करके मृत्यु उत्पन्न करती है।

महर्षि वाग्भट ने भी लिखा है कि अति स्थूल स्तन वाली धात्री (बालक को) ग्रीवास्तम्भ, ऊर्ध्व स्तनी बालक को ऊर्ध्वोक्ष तथा लम्ब स्तनी उच्छ्वासवरोध कर (बालक के) जीवन में ही संशय उत्पन्न कर देती है।

Suckling with over erect breasts makes the child *karāla* (terrible face with wide oral aperture) or *urdhwākṣa* (upwards looking), corpulent breasts produce neck-rigidity and dangling breasts cover the face and nose thus cause asphyxia and death of the child.

विमर्श (Comments)

चूड़क-विकृति में उन्हें भलीभाँति पकड़ सकने की असमर्थता के कारण बालक पूर्णरूपेण दुग्ध-पान नहीं कर पाता अतः पोषण जन्य विकारों से पीड़ित हो सकता है, परन्तु क्रियात्मक क्षेत्र में स्तनों के आकार से बालक में किसी भी प्रकार के विकार देखने को नहीं मिलते, फिर भी उत्पन्न वर्णन के आधार पर ऐसा मान सकते हैं कि स्तन अधिक ऊँचे या स्थूल होने पर बालक के लगातार ऊपर देखने से या उसकी ग्रीवा पर वजन पड़ने से कुछ शारीरिक विकृतियाँ आ जाँय।

Abnormalities of nipples do cause difficulty in sucking, thus, due to deficient intake of milk the child may suffer from various nutritional abnormalities. Shape and size of the breasts are not related with their capacity of production of milk and also do not influence in any way the child's facial expression. However, it may be presumed that while sucking the too high breasts the child may have to look continuously upwards with strain to the neck, which may cause some facial abnormality.

स्तनपान-विधि (Method of breast feeding)

धात्री तु यदा स्वादुबहुलशुद्धदुग्धा स्यात्तदा स्नातानुलिप्ता शुक्लवस्त्रं परिधादैर्न्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्यामपोधामव्यथा शिलामारिष्टां वाट्यपुष्पीं विष्वक्सेनकान्तां वा बिभ्रत्याषधिं कुमारं प्राङ्मुखं प्रथमं दक्षिणं स्तनं पादयेत् । इति धात्रीकर्म ॥ (च० सं० शा० ८/५८)

ततः प्रशस्तायां तिथौ शिरःस्नातमहत्वासासमुद्रमुखं शिशुमुपवेश्य धात्री प्राङ्मुखीं चोपवेश्य दक्षिणं स्तनं धौतमीषत्परिचुतमभिपमन्य मन्त्रेणानेन पादयेत् ॥ २५ ॥

चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीरवाहिनः । भवन्तु सुभयो नित्यं बालस्य बलवृद्धये ॥ २६ ॥
पयोऽमृतसं पीत्वा कुमारस्य शुभानने । दीर्घमायुस्त्वान्नेतु देवाः प्राश्यामन्तं यथा ॥ २७ ॥

(सु० सं० शा० १०/२५ से २७)

अथ धात्री स्नातानुलिप्ता नित्यमहत्वासाः सुभगाः प्रजास्थापनौषधीः शिरसा विभ्रणा प्राङ्मुखी स्तनं प्रादक्षिणं धौतमीषत्परिचुतं पादयेत् ॥ (अ० सं० उ० १/२२)

धात्री जब प्रचुर मात्रा तथा मधुर दुग्ध वाली हो तब वह स्नान, अनुलेपन एवं रस्ते (स्वच्छ) वस्त्र धारण कर, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्रवीर्या, अमोघा, अलघा, शिवा, अरिष्टा, वाट्यपुष्पी एवं विष्वक्सेनकान्ता (ये सभी प्रजास्थापन औषधियाँ हैं) आदि में से सभी या उचितव्य इन्हीं को धारण कर, पूर्व की ओर मुख करके (बैठकर) बालक को सर्वप्रथम दक्षिण स्तन का पान कराए। यह धात्री-कर्म समाप्त हुआ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि तदनन्तर प्रशस्त तिथि में, शिर से स्नान कराए हुए, नए वस्त्र पहनाए हुए बालक को, पूर्वाभिमुख बैठी हुई धात्री की गोद में उत्तर की ओर मुख करके बैठाए एवं स्तनों को धोकर धौड़ा सा (स्तन्य) बाहर निकाल कर निम्न मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके स्तनपान कराए।

“हे सुभयो ! बालक की बल-वृद्धि के लिए चारों समुद्र तैरे स्तनों से निरन्तर क्षीरवाहक हों। हे शुभानने ! जिस

प्रकार अमृत-प्राशन करके देवताओं ने दीर्घायु प्राप्त किया, उसी प्रकार अमृत रूप दुग्ध को पी कर कुमार दीर्घायु प्राप्त करें।^१

महर्षि चाण्ड ने संक्षेप में लिखा है कि धात्री स्नान एवं अनुलेपन तथा नए वस्त्र पहन कर, प्रजापत्यपन औषधियों को शिर में धारण कर, पूर्वाभिमुख बैठकर, स्तनों को धोकर तथा थोड़ा सा (स्तन्य) बाहर निकाल कर पहिले दक्षिण स्तन का पान कराए।

आचार्य भावमिश्र ने शब्दभेद से महर्षि सुश्रुत का अनुगमन करते हुए मनोस्त्रेख भी किया है^१।

सम्भवतः महर्षि सुश्रुत एवं अयुगामी भावमिश्र का उपर्युक्त वर्णन धात्री के द्वारा स्तनपान प्रारम्भ करने के प्रथमः दिन का ही है क्योंकि निरूपति पान करने में प्रशस्तिविधि के विचार का प्रश्न नहीं उठता।

When the wet-nurse has sweet milk in sufficient quantity, then after taking bath, anointing herself and wearing white garments, should tie (on head or any other body part) all or available drug out of *aindā, brāhmi, śālavīryā, sahasaravīryā, amoghā, avyathā, śivā, arisā, vāṇṇapāpi* and *viṣwakṣendakāntā* (all these are *prajāśāhīpāna* drugs). Now she should sit facing to the east and give first her right breast to the child.

Sūśruta says that on auspicious date the child should be bathed form head to toe, clothed with new garments and made to sit facing towards north, over the lap of wet-nurse who is sitting facing eastwards. The wet-nurse after washing the breasts and expressing out little quantity of milk, should start breast feeding with enchantation of following *mantra*.

“O fortunate pretty woman! all the four seas should produce constant flow of milk from your breasts for increase in strength of the child. O beautiful woman! as the deities obtained longevity by consuming nectar, similarly the child should also get longevity by consuming your milk which is similar to nectar”.

Almost identical description is given by Vāgbhata I and Bhāwaprakāśa.

नाना स्तन्यपान का परिणाम (*Effect of lactation by different women*)

अतोऽन्यथा नानास्तन्योपायोऽस्यास्तन्याद् व्याधिजन्म भवति ॥ (सु० सं० शा० १०/२८)

नानास्तन्यस्य ह्यसाम्यत्वाद्वाभाव्या व्यापदो भवति ॥ (अ० सं० उ० १/२३)

नाना स्तन्योपायोग (अनेकों स्त्रियों के दुग्ध का पान) से, असाम्य होने के कारण व्याधियों का जन्म होता है।

महर्षि चाण्ड ने भी लिखा है कि नाना प्रकार के स्तन्य असात्म्य होने के कारण अनेकों व्याधियों के उत्पन्नक होते हैं।

If the child is given breast milk of different women or in other words lactating woman is frequently changed, then the child suffers from various diseases because this changed milk becomes non-congenial to him.

१. तत्र माता प्रशस्तान्नी चारुकरा पुष्टिमुखी। उपविश्यासने सम्यग्दक्षिणं स्तनमनुत्ता ॥ ३० ॥

प्रशाल्येषत्तरिक्षाव्य मन्त्राभ्यामभिन्निजन्तम्। उदङ्मुखं शिशुं क्रोडे शनैः सन्ध्या पाययेत् ॥ ३१ ॥

(माता-इन्दुपक्ष्मणम्। धात्री चेषत्तरिक्षाव्य)

क्षीरनीनिधिस्रोतस्तु स्तनयोः क्षीरपूरकः। सदैव सुप्तो बालो भवत्येष महाबलः ॥ ३३ ॥

पयोऽमृतसमं पीत्वा कुमारस्ये शुषमने। दीर्घमयुर्बालान्नु देवाः प्राच्यामृतं यथा ॥ ३४ ॥ (पा० प्र० पूर्व० ४)

विमर्श (Comments)

धात्री-निष्ठुकि के महत्त्व को दर्शाते हुए आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि यदि एक धात्री के अतिरिक्त अनेकों स्त्रियों का स्तन-पान शिशु को कराया जाय तो वह स्तन्य शिशु को असात्म्य हो सकता है। स्तन्य में उपस्थित पोषक एवं अन्य तत्वों में व्यक्तिगत वैभिन्न्य होता है, शिशु को एक प्रकार का स्तन्य सात्म्य हो जाता है। यह सम्भव है कि बार-बार दुग्ध का परिवर्तन होने से वह उसे सात्म्य न कर पाए एवं असात्म्य होने के कारण अनेकों व्याधियों से ग्रसित हो जाए।

There may be slight variation in the composition of breast-milk of individual woman. The child may get acclimatized to one particular composition, naturally if milk is changed frequently, the child might not be able to digest it properly.

अपरिस्तुत स्तन्यपान जन्य विकार (*Diseases due to feeding with unexpressed breasts*)

अपरिस्तुतेऽप्यतिसब्धस्तन्यपूर्णस्तनपानात् उत्सृष्टितनोत्सः शिशोः काशश्वासवमीप्रादुर्भावः ॥

अपरिस्तुते चातिसन्यपूर्णस्तनपानोत्सोऽहनात् काशश्वासवमिप्रादुर्भावः सम्भवः ॥ (सु० सं० शा० १०/२९)

अपरिस्तुत न करने पर, अतिस्तब्ध एवं स्तन्य से पूर्ण स्तन का पान करने से, ऊर्ध्व सेतसों के पर जाने के कारण बालक को काश, श्वास एवं वमन हो जाता है। (अ० सं० उ० १/२३)

महर्षि चाण्ड ने भी यही लिखा है कि अपरिस्तुत होने पर स्तनों के स्तन्य से अति परिपूर्ण होने के कारण उनके पान से स्तन्य के विमर्श में जाने या उसके स्नेह के अन्तर्गमन^१ से (स्तन्य के सामान्य मार्ग या अन्न प्रणाली में न जा श्वासप्रणाली में जाने से) बालक को काश, श्वास, ज्वर एवं छर्दि होने की सम्भावना रहती है।

आचार्य भावमिश्र ने भी उपर्युक्त विचार ही व्यक्त किए हैं^१।

If the breasts are not slightly squeezed or milk is not drained, then these become tense due to over accumulation of milk. If child sucks these tense breasts, his *strotasas* (situated in upper body part) get filled or else milk goes in abnormal passage and produces cough, dyspnoea, vomiting and fever etc. disorders.

विमर्श (Comments)

अधिक देर तक स्तन-पान न करने से या कभी कभी ऐसे भी स्तनों में अत्यधिक स्तन्य एकत्र हो जाता है, जिसके कारण स्तन कड़े हो जाते हैं, एवं शिशु द्वारा स्तन-पान किए जाने पर कड़ेपन के कारण उसे प्रारम्भ में कुछ कष्ट भी हो सकता है। दुग्ध के अति मात्रा में सञ्चय के कारण वह अधिक मात्रा में तथा बहुत ही तेजी से आ सकता है, वच्चा उस मात्रा को सामान्य रूप से निगलने में असमर्थ हो सकता है, तथा कुछ अंश विमर्श या श्वासनलिका में जाकर या गले में अटक कर उपर्युक्त व्याधियाँ उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा सा दूध निकाल देने से वह स्थिति नहीं होगी। महर्षि सुश्रुत ने इसीलिए नाना-स्तन्य तथा अपरिस्तुत-स्तन्य-पान का निषेध किया है^१।

The child may find some difficulty in sucking a breast which is tense and over filled

१. उत्सृष्टेन तन्नेहस्यान्तर्गमनम्। (अ० सं० उ० १/२३ की इन्दु टीका)

२. अस्माकितं स्तनं बालः शिवस्तन्येन पूर्यते। पूर्णलोला वमीकासश्चासैर्भवति पीडितः ॥ (पा० प्र० पूर्व० ४/३२)

३. तस्मादेवं विधानं स्तन्यं न पाययेत् ॥ (सु० सं० शा० १०/२९)

with milk, besides he may not be able to swallow the milk properly due to its sudden overflow, thus the milk may trickle into trachea and produce cough etc. complications. Gentle squeezing of breasts before lactation ensures patency of lactiferous tubules and also avoids above complications.

स्तन्यापन वर्जित अवस्थायें (The woman unfit for suckling)

न च क्षुधितशोकातश्चान्द्रप्रदुष्टधातुगर्भिणीचरिततिक्षीणतिसृष्टलविदग्धभक्तविरुद्धाहारतर्पितायाः स्तन्यं पाययेत्, नाजीर्णौषधं च बालं, दोषौषधमलानां तीव्रवेगोत्पत्तिभयात् ॥ (सु० सं० शा० १०/३९)

न तु क्षुधितशोकातश्चान्द्रप्रदुष्टधातुगर्भिणीविरुद्धाहारभुक्तानां स्तन्यं पाययेन्नाजीर्णौषधं च बालमिति । भवति चात्र ॥ (अ० सं० उ० १/२५)

विरुद्धाहारभुक्तयाः क्षुधितया विवेतः । प्रदुष्टधातुगर्भिण्याः स्तन्यं योगकरं शिशोः ॥

(अ० ह० उ० १/१९)

क्षुधित, शोकात, श्रान्त, धातु-दोष-पीडित, गर्भिणी, ज्वर-पीडित, अतिक्षीण, अतिस्थूल, विदहजनक तथा विरुद्ध आहार की हुई (माता या धात्री) बच्चे को दूध न पिलावे । दोष, औषध एवं मलों की तीव्र वेगोत्पत्ति के भय से बालक के द्वारा प्रयुक्त औषधि के जीर्ण हो जाने तक भी स्तन-पान न करावे ।

अष्टाङ्गसंग्रह में भी लिखा है कि क्षुधित, शोकात, श्रान्त, क्रुद्ध, प्रदुष्ट-धातु, गर्भिणी, विरुद्धाहार-भुक्त स्त्री तथा औषधि के जीर्ण न होने तक बालक को दूध-पान न करावे ।

अष्टाङ्गहृदय में भी यही लिखा है कि विरुद्ध आहार खाई हुई, क्षुधित, विकृत चित्त वाली (शोक, क्रोधादि मानसिक-व्याधि पीडित या अन्धमनस्क), प्रदुष्ट-धातु तथा गर्भिणी स्त्री का स्तन्य शिशु के लिए योगकारक होता है ।

The woman who is hungry, stricken with grief, tired, has vitiation of *dhatus*, is pregnant, suffering from fever, emaciated, obese and has consumed diet likely to produce *vidāha* (burning sensation or indigestion) or the edibles opposite in character, should not give breast-feeds to the child. The child whose recently ingested medicine is not assimilated should also not be given the feed, because at this stage the force of *dosas*, *ausadhi* (drugs) and *mala* (excretas) is too much.

Vāgbhaṭa I has advised to avoid breast feeding even by the woman who is angry and Vāgbhaṭa II by the woman who has psychological abnormalities or reluctance for feeding.

विमर्श (Comments)

माता की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ उसके स्तन्य की मात्रा को प्रभावित एवं उसे दूषित भी कर सकती हैं; यह भी संभव है कि मानसिक रूप से शांत न होने के कारण असम्यक् रूप से स्तन-पान करने पर दूध बालक की क्षासनलिका में जाकर व्याधियाँ उत्पन्न करे । यदि बालक ने औषधि-सेवन किया है और वह औषधि पूर्णरूपेण पचित नहीं हुई, उस स्थिति में उसके शरीर में स्थित दोष, औषध एवं मलों का वेग तीव्र होता है, ऐसे समय में यदि वह बालक दूध पियेगा तो उसे व्याधियाँ हो सकती हैं ।

Physical and psychological disorders of woman influence quality and quantity of milk, besides psychologically upset woman may not take proper care while feeding, thus, milk may trickle in the trachea of the child and may produce various disorders. *Doshas* and *malas*

remain agitated and force of medicine is a bit more at the time of assimilation of medicine taken by the child, thus, ingestion of mother's milk during this stage may produce diseases to the child.

स्तन्यसम्पत् या शुद्ध स्तन्य के लक्षण (Shanyasampat or characteristics of normal breast-milk)

स्तन्यसंपत्तु प्रकृतिवर्णन्यारसस्पर्शम्, उदपात्रे च दुह्यमानमुदकं व्यति प्रकृतिभूतत्वात्; तत्पृष्ठिकारमारोग्यकरं वेति, (स्तन्यसंपत्) ॥ (च० सं० शा० ८/५४)

यक्ष्मीमुदके क्षिमेकोभवति पाण्डुरम् । मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तद् विनिर्दिशेत् ॥

(सु० सं० ति० १०/२५)

अथारयाः स्तन्यमप्युपरीक्षेत, तच्चेच्छीतलममलं तनु शङ्खवभ्रासमप्यु न्यस्तमेकीभावं गच्छत्यफेनिलमलतनुमन्नो-त्पन्नतेजस्वीति वा तच्छुद्धमिति विद्यात्, तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलवृद्धिश्च भवति ॥

(सु० सं० शा० १०/३९)

तच्चोदकपात्रे दुह्यमानमेकतां यदुदकेन सह गच्छति वक्ष्यमाणदोषरहितं च तच्छुद्धमारोग्यबलजननम् ॥

(अ० सं० उ० १/२९)

यद्विद्वरेकतां याति न च दोषैरधिष्ठितम् । तद्विशुद्धं पयः ॥ (अ० ह० उ० २/२)

अव्याहतबलाङ्गायुरोगो वधेति सुखम् । शिशुधात्र्योर्नापातिः शुद्धक्षीरस्य लक्षणम् ॥

(का० सं० सू० १९/२६)

जिस दूध का वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श प्राकृत रूप में अर्थात् सामान्य हो, जल-युक्त पात्र में डुबे जाने पर उसके साथ एक समान मिल जाय, वह सामान्य या उत्तम होने के कारण पुष्टि एवं आरोग्य कारक (बालक को) होता है । यह दूध का सम्पत् होना या उत्तमता है ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि जो दूध धात्री में डालने पर एकीभूत हो जाय, पाण्डुवर्ण, मधुर तथा विवर्णता रहित हो उसे शुद्ध स्तन्य जानना चाहिए ।

पुनःश्च लिखा है कि अब इसके (धात्री के) स्तन्य की जल में परीक्षा करनी चाहिए, यदि वह शीतल, निर्मल या स्वच्छ, तनु, शीघ्र के समान आभा (वर्ण) वाला हो, जल में डालने पर एक हो जाय (अर्थात् उसमें भरी भाँति मिल जाय, पृथक करना सम्भव न हो), फेन तथा तन्तु रहित हो, जल में (डालने पर) न तैरता हो न ही डूबता हो, उसे शुद्ध स्तन्य समझना चाहिए । इससे (इस प्रकार के दूध पान से) बालक के आरोग्य, शरीर के उपचय तथा बल की वृद्धि होती है ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने संक्षेप में लिखा है कि यदि वह दूध उदकपात्र में डुबे जाने पर तत्काल ही पानी में मिल जाय तो उसे दोष रहित समझना चाहिए । यह शुद्ध स्तन्य आरोग्य एवं बलदायक होता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी यही लिखा है कि जो जल के साथ एकरूपता को प्राप्त हो जाता है, दोषों से व्याप्त (दूषित) नहीं रहता वह शुद्ध दूध है ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि (जिस दूध के पान से) बालक के बल, अङ्ग, आयु तथा आरोग्य निर्वाध रूप से, सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त हों, शिशु एवं धात्री को कोई कष्ट न हो, यही शुद्ध क्षीर के लक्षण हैं ।

महर्षि हरीत ने स्तन्यविकारों के पाँच भेद वर्णन करते हुए मृदु क्षीर को सामान्य माना है तथा उसके पान से बालक

को सत्त्व एवं बल की प्राप्ति तथा अरोग्य-लाभ होने के साथ ही उसे रूपवान होने का वर्णन दिया है^१।

अन्य दुग्ध के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि दुग्ध स्रोतों को शुद्ध करने वाला, बलकाक, दोषनाशक, त्रिदोषनाशक, वृष्य एवं अग्निवर्धक होता है^१।

माधवनिदान एवं योगरत्नाकर^२ पुस्तकों में सुश्रुत निदानस्थान वर्णित लक्षणों का तथा भावप्रकाश में शरीरस्थान वर्णित लक्षणों का ही उल्लेख है^३।

The milk which is normal in colour, smell, taste and touch, and when milked in a pot filled with water mixes evenly, is known as pure milk. This milk provides nourishment and good health to the child.

Suśruta says that the pure milk is cold, clean or free from impurities, whitishyellow or white just like the colour of conch-shell, sweet in taste and free from discolouration, when put in water, it mixes evenly, neither produces froth nor streaks, neither floats nor settles down. This type of milk provides good health, growth and development of body as well as strength to the child.

Both the Vāgbhāṣas agreeing with above say that it should not be vitiated by *doṣas*. Kāśyapa without mentioning any physical characters says that the pure milk is that which provides unobstructed, easy and good growth of strength, different body parts, longevity as well as good health to the child and does not cause any pain or trouble to the child and wet-nurse.

Hārīta defining *mādhukṣīra* as pure milk adds *satwa* and beauty also in the list which are achieved by using pure milk.

Mādhavābhīdāna, Yogarahamākāra and Bhāvaprakāśa have followed Suśruta.

नैल वर्णीदि सत्त्व-पान का प्रभाव (Effect on the child of the milk having different colours)

नैलवर्णों वाली तुल्या घृतवर्णों महाधनः । यशस्वी धूमवर्णों तु शुद्धे सर्वगुणोदितः ॥ (का० सं० सू० १९/३, ४)

नैल वर्ण के सत्त्व का पान करने से बालक बलवान्, घृत वर्ण के सत्त्व-पान से महान धनी (अत्यधिक धन एवं ऐश्वर्य वाला), धूम वर्ण के सत्त्व-पान से यशस्वी तथा शुद्ध सत्त्व-पान से सर्वगुण सम्पन्न होगा ।

Consumption of milk having different colours produces following qualities in the child—

१. (अ) मुद्गशीरा भवेत्सौख्या.....॥ २॥

सुसत्त्वं बलमान्जीति चारोग्यं लभते शिशुः । मुद्गशीरा नियतं जायते रूपवान्पि ॥ ६॥ (हा० सं० तुली० ५४/२, ६)

(आ) स्रोतोविशुद्धकरणं बलवृद्धौषनाशनम् । पयस्विदोषशमनं वृष्यश्लाघिप्रवर्द्धनम् ॥ (हा० सं० प्र० ८/१३)

२. (अ) अमुद्गं चान्युनिक्षिप्तमेकीभवति पाण्डुरम् । मधुरं चाविर्ण्यं च प्रसन्नं तत् प्रशस्यते ॥ (पा० नि० ६७/८)
(आ) अमुद्गं । तत्प्रसन्नं विनिर्दिशेत् ॥ (पा० नि० सद्दुग्ध) (यो० २० क्षीदोष वि०)

३. नैर सत्त्वं यदीकं स्यादविर्ण्यमर्तनुमत् । पाण्डुरं तनु सीतं च तद् दुग्धं शुद्धमादिशेत् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ४/२३)

Colour of milk resembling to	Qualities in the child
Oil	Very strong
Chitra	Very rich
Smoke	Renowned.
Pure milk	All the qualities.

स्तन्यनाश एवं स्तन्यक्षय (Stanyanāśa and stanyakṣaya)

(१) स्तन्यनाश-हेतु (Causes of stanyanāśa or cessation of milk formation)

क्रोधशोकवातासत्त्वदिभिश्च स्त्रियाः स्तन्यनाशो भवति ॥ (सु० सं० शा० १०/३०)
रक्षात्रापानकर्षणक्रोधशोककामादिभिः स्तन्यनाशः ॥ (अ० सं० उ० १/२४)
शुक्रक्रोधलङ्घनाऽप्यासः स्तन्यनाशस्य हेतवः । (अ० ह० उ० १/१७)
शोधानाद्वा स्वभावान्नाद्वयस्याः क्षीरे विशुष्यति । तस्याः क्षीरप्रजनने प्रयतेत विचक्षणः ॥

(का० सं० सू० १९/१८)

क्रोध, शोक, अवातसत्त्व (बच्चे के प्रति प्रेम न होना) आदि स्त्रियों में स्तन्यनाश के कारण है । टीकाकार इन्हें पाने आदि शब्द से लंघन एवं व्यायाम का भी समावेश किया है^१।

अष्टाङ्गसंहकार ने लिखा है कि रक्ष अन्न-पान का सेवन, कर्षण, क्रोध, शोक तथा काम (अत्यधिक मैथुन) आदि स्तन्यनाश के कारण हैं ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि शोक, क्रोध, लंघन एवं अपास स्तन्यनाश के कारण हैं ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि शोषण (द्रव्यों या कर्म) के प्रयोग (अतियोग) से अथवा स्वभाव के कारण जिस स्त्री का दुग्ध सूख जाय उसे क्षीरजनन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए ।

आचार्य भावमिश्र ने अवातसत्त्व, धम, शोक के ही साथ अत्यन्त अपतर्पण एवं (दूसा) गर्भधारण करना भी लिखा है^२।

Anger, grief, absence of affection for the child, fear, fasting, excessive exercise, consumption of dry (free from oleaginous substances) edibles and drinks, emaciation, excessive use of purifying measures and re-pregnancy are the causes of cessation of milk.

२) स्तन्यक्षय के लक्षण (Clinical features of stanyakṣaya or loss of milk)

स्तन्यक्षये स्तनयोन्मीलता स्तन्यासम्भवोऽप्यता वा । (सु० सं० सू० १५/१२)

स्तन्यक्षय में स्तनों में प्दानता (ढीलापन) तथा स्तन्य की असम्भवता या अनुपस्थिति तथा अल्पता लक्षण होते हैं ।

आचार्य भावमिश्र ने भी उपर्युक्त आशय का ही वर्णन दिया है^३।

१. आदिशब्दाश्लिङ्गनव्यायामादयः ॥ (सु० सं० शा० १०/३० की इल्ल० टीका)

२. अवातसत्त्वद्राज्योकात्क्रोधोपादयत्पर्यणत् । स्त्रीणां स्तन्यं भवेत्स्वल्पं गर्भान्तविधारणात् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ४/१०)

३.स्तन्यस्य भवतासथा ॥ ११॥

मलानौ पयोधारावैतल्लक्षणं स्तन्यसंक्षये ॥ (पा० प्र० पूर्व० ७/११, १२)

Laxity of breasts alongwith decrease in quantity or absence of milk secretion are the clinical features.

स्तन्यनाश एवं स्तन्यक्षय की चिकित्सा (Treatment of stanyanāśa and stanyakṣaya)

(अ) स्तन्यक्षय-चिकित्सा (Treatment of stanyakṣaya)

- (१) रतेष्वन-वर्धक द्रव्यों का प्रयोग करने से स्तन्यक्षय दूर होता है^१।
- (२) सुरा, शालि, अन्न, मांस, गोक्षीर, शर्करा, आसव, दधि तथा हृद्य (वाँछित) वस्तुओं का प्रयोग स्तन्यक्षय-पीड़ित स्त्री के लिए लाभदायक होता है^१।
- (३) स्तन्यक्षय या स्तन्यनाश में वमन का प्रयोग निषिद्ध है^१।
- i) Use of articles capable of increasing the śleṣmā cure stanyakṣaya.
- ii) Wine, śālī cereals, meal, cow's milk, sugarcane, curd and use of desired things cure stanyakṣaya.
- iii) Emesis is contraindicated.

आ) स्तन्यजनन द्रव्य या क्षीरवर्धक कषाय (Stanya janana drugs or the drugs increasing quantity of milk)

वीरपशुप्रतिषिद्धैश्वर्यालिकादपंक्तुशकाशगुद्रेकटकतृणमूलानि दशेभानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥

(च० सं० सू० ४/१७)

वीरप, शालि, षटिक (दोनों धान्य विशेष), इशुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुन्ना (एक या भद्रमुन्ना) इत्कट एवं कणुण के मूल ये दश स्तन्यजनन औषधियाँ हैं।

Roots of vīraṇa, śālī, ṣaṭika, iṣuvalīkā, darbha, kuśa, kāśa guṇḍrā, itkāṭa and kairṇa are ten stanyajanana drugs. These may be used in the form of decoction.

(इ) स्तन्यनाश की अन्य चिकित्सा या क्षीरवर्धक द्रव्य (Other treatment of stanyanāśa or drugs capable of increasing amount of milk)

स्तन्य के वर्धन के लिए निम्न औषधियों या द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए-

- (१) सौषु नामक मंदिरा को छोड़कर अन्य सभी मंदिराये^{१,३,४} या मध्व^१।
- (२) ग्राम्य, आनूप^{३,४} तथा औदक शाक, धान्य^{१,३,४} अथवा केवल मांसरस विशेषकर वराह एवं महिष को छोड़कर अन्य सभी।
- (३) द्रव^{१,५}, मधुर^{१,३}, अम्ल एवं लवण भूयिष्ठ अन्नपान^{१,३,४}।
- (४) क्षीरिणी औषधियाँ अर्थात् जिन औषधियों में दृश्यमान क्षीर रहता है यथा दुग्धिका, कलत्रिका आदि^{१,३,४}।

१. तत्र स्तेष्वनवर्धद्रव्योपयोगः ॥ (सु० सं० सू० १५/२२)

२. सुराशास्त्रनासांनि गोक्षीर शर्करा तथा । आसव दधि हृद्यानि स्तन्यक्षीणाऽभिवृज्यति ॥ (पा० प्र० पूर्व० ७/११२)

३.अल्पक्षीरा लघुक्षीरा नष्टक्षीरा.....न वाय्वाः..... ॥ (का० सं० सि० ७/५)

नोट - स्तन्यनाश की अन्य चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ६५६, ६५७ में देखें।

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

- (५) क्षीर-पान^{१,३,४,५,६}।
- (६) परिश्रम न करना या आराम करना^{१,३,४} तथा निद्रा-सुख^१।
- (७) वीरप, षटिक, शालि, इशुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुन्ना, इत्कट एवं कणुण के मूल के कषाय का पान क्षीर-जनक होता है^१।

(८) स्तन्य-क्षय के अन्तर्गत वर्णित सभी चिकित्सा।

- (९) मन की प्रसन्नता^{३,३,६} तथा शोक^४ एवं क्रोध, अत्यधिक मार्ग-गमन तथा भय एवं आयास का परित्याग^१।
- (१०) यव, गेहूँ, शालि, षटिक^१, मांसरस^१, सुरा, सौवीर (काञ्ची), पिप्पलाक (तिलकच्छक), लशुन, मत्स्य या क्षुद्रमत्स्य, कशेरुक, शृङ्गाटक^१, विष, विदारीकन्द, मधुक, शलावरी, नलिका, अलाबू, कालशक^१ तथा नारिकेल आदि का सेवन करावे^१।

(११) गुड़ के साथ सिद्ध किया हुआ तथा हिङ्गु एवं जातीफल से सुसंस्कृत नाड़ी शाक^१।

(१२) जाजीकरण औषधियों से सिद्ध क्षीर^१।

(१३) घृत एवं तैल का सेवन^१।

(१४) आस्थानन बस्ति-प्रयोग^{३,३,५}।

(१५) लशुन एवं फलण्डु का सेवन^१।

(१६) सिद्धार्थक को छोड़कर अन्यशाक^१।

(१७) वट आदि क्षीरि वृक्षों तथा क्षीरिका के वल्कल का कषाय बनाकर उसके साथ दुग्ध को सिद्ध करें तथा इसमें पाक्य (पाशु या सौवर्धल लवण) गुड़, विड (विड लवण) तथा घृत मिलाकर शालि (चावलों का ओदर) का भोजन करें, इस प्रयोग से शुष्क स्तनों वाली स्त्री को भी स्तन्य की उत्पत्ति हो जाती है^१।

(१८) शालि, षटिक, दर्भ, कुश, गुन्ना, इत्कट, साखि, वीरप, इशु, कुश तथा काश की मूल से उर्गुक विविध के द्वाया क्षीरपाक करके सेवन करें। स्वभाव से ही नष्ट, शुष्क अथवा दूषित (दृष्टि दोष से) दुग्ध के लिए यह उत्तम औषधि है^१।

(१९) मरिच एवं पिप्पलीमूल से सिद्ध दुग्ध^१।

(२०) मागधी, नागर तथा पय्या एवं बी मिलाकर दुग्ध-पान^१।

(२१) कलम नामक धान्य विशेष के चावलों को दुग्ध में पीस कर जो स्त्री सेवन करती है उसके दोनों स्तन दुग्ध के भार से अति उन्नत हो जाते हैं^१।

(२२) विदारीकन्द का रस अथवा विदारीकन्द का चूर्ण दुग्ध के साथ^१ अथवा भूमिकृष्णाड मूल (विदारीकन्द) को दुग्ध के साथ पीस कर उसका रस निकाल कर शर्करा मिलाकर पान अथवा विदारीकन्दचूर्ण का सुरा के साथ पान^१।

(२३) शलावरी को गोदुग्ध के साथ पीसकर पान^१।

(२४) कवोषा दुग्ध के साथ कण-चूर्ण का पान^१।

(२५) वनकर्पास तथा इशु के जड़ के चूर्ण का सौवीर (काञ्ची) के साथ पान^१।

(२६) वज्रकाञ्ची नामक योग का प्रयोग-पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, शुण्ठी, यवानिका, दोनों जीरक, दोनों हरीद्रा,

१. नोट-सन्दर्भ पृष्ठ ६५६, ६५७ में देखें।

विड तथा सौवर्चल लवण को (पीसकर) काशी के साथ पकावे। इसे प्रसूता स्त्री अग्नि-वर्त के अनुसार पिये। यह चक्रकाष्ठिक नामक योग अमवातहर, वृष, कफघ्न, वातनाशक, अग्निवर्धक, मक्कल्लुल-नाशक तथा क्षीरवर्धक है।

Use of the following increases quantity of milk—

- Except *sīdhu* all other wines.
- Vegetables growing wildly or on marshy land or water, cereals, meat or meat soup except meat of hog and buffalo.
- Estables and drinkables which are predominantly liquid, sweet, sour or saltish.
- Drugs which possess apparent latex such as *dagdhikā* and *kalanbikā* etc.
- Milk.
- Not to toil or work hard, rest and good sleep.
- Decoction of roots of *virāṇa*, *saṣṭika*, *śāli*, *ikṣuvālikā*, *darbha*, *kuśa*, *kāśa*, *gundrā*, *itika* and *katrya*.
- Treatment prescribed for *stanyaakṣaya*.

- क्षीरजननी तु मद्यानि सीधुज्वानि, ग्राम्याण्यौदकानि च शाकधान्यांसांनि, द्रवमधुरालतलवणभृविष्टाश्चक्षराः, क्षीरिष्य-क्षीरधमः क्षीरपाननायासश्च, वीरणावष्टिकशातोद्भवास्तिकादभक्षुशकाशुगुद्रेक्तकणुगुलकपायाणां च पानमिति (क्षीरजन-नानि) ॥ (क्षीरिष्यश्च दुष्टिकाकलीबकादयो दुग्धमानक्षीराः—चक्राणि) (च० सं० शा० ८/५७ एवं चक्र० टीका)
- (अ) अथास्याः क्षीरजननायै सौमनस्यमुत्पाद्य यवगोधूमशालिषष्टिकमांससुसुप्तसौवीरकपिष्यकालशुननस्यकशेरुकभृङ्गाटक-विस्विदीकन्दमधुकशरावतीनलिकालाबूकालशाकभृतीनि विदध्यात् ॥ (सु० सं० शा० १०/३०)
(आ) ...वर्तिकर्म.....स्तन्याशः.....चात्यधमुपयुज्यते ॥ (सु० सं० चि० ३५/५)
- (अ) स्तन्यजननी तु मद्यानि सीधुज्वान्यानूपमांसांनि दवाः स्वाद्वलतलवणप्रपायाश्चक्षराः क्षीरिष्यक्षीरधमः क्षीरपाननायासः सौमनस्यं च ॥ (अ० सं० उ० १/२४)
(आ) ...तत्रास्याप्या.....स्तन्याशो.....। (अ० सं० सू० २८/१०)
- स्तन्यस्य सीधुज्वानि मद्यान्यनूपजा रसाः। क्षीरं क्षीरिष्य औषधः शोकादीनां विपर्ययः ॥ (अ० ह० उ० १/१८)
- (अ) नाडिका सगुडा सिद्धा हिङ्गुजातिसुस्तम्बला। क्षीरं मांससो मद्यं क्षीरवर्धनमुत्तमम् ॥
वाजीकाणसिद्धं वा क्षीरं क्षीरविवर्धनम्। घृतैर्लोपसेवा च बरस्तयश्च पर्यस्कतः ॥
मधुराधरापानानि द्रव्याणि लवणानि च। मद्यानि सीधुज्वानि शाकं सिद्धार्थकादृते ॥
वराहमहिषादूर्ध्वं मांसानां च रसो हितः। लशुनानां पलाण्डूनां सेवनं शयनं सुखम् ॥
(क्रोधाच्च) पशोकानामायासानां च वर्जनम्। अ.....या भवति वर्तस इति क्षीरविवर्धनम् ॥
वटदीनां च वृक्षाणां क्षीरिकायाश्च वल्कलम्। पयस्यः कषायः कृधितः क्षीरं तेन पुनः शृतम् ॥
पयस्यं गुडविद्योतेतं सघृतं शालिमशयेत्। अपि शुष्कस्तनीनां तत् क्षीरोपजननं परम् ॥
शालिषष्टिकदर्मणां कुशगुद्रेक्तस्य च। सारिवावीरणेषूणां मूलानि कुशकाशयोः ॥
येयानि पूर्वकल्पेन श्रेष्ठं क्षीरविवर्धनम्। स्वभावान्दे शुक्लं वा दुग्धे सास्त्रीक्षिते हितम् ॥

(आ)अल्पविशुष्कदुग्धा। (का० सं० कल्प० ७/८४)

(का० सं० सू० ११/१०, ११, ११ से २५)

क्रमशः

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

ix) Happiness, absence of sorrow, anger, fear, and tiring work as well as avoidance of excessive walking.

x) Barley, wheat, *śāli*, *saṣṭika*, meat-soup, wine, *kāyī* (fermented sour drink), pestled *nīla*, *laśūna*, fish, *kaśerika*, *śrīṅgātaka*, *bīsa*, *vidārīkanda*, *madhuka*, *śātāwar*, *nalikā*, *atābū*, *kālaśāka* and *narikela* etc.

xi) *Nāṭśāka* cooked with jaggery and mixed with *hingu* and *jāiphalā*.

xii) Milk treated with *vājīkaraṇa* drugs.

xiii) Use of *ghṛta* and oil.

xiv) Use of *āsthāpāna basti* (evacuative enema).

xv) Use of *laśūna* and *palāṇḍi*.

xvi) Except *siddhārthaka* all other leafy vegetables.

xvii) Milk should methodically be cooked with the decoction of stem bark of *vaṭa* etc. latex-yielding trees and *ksīrikā*. This milk mixed with *sauwarcala* and *wid* salts, jaggery and *ghṛta* should be taken with cooked *śāli* rice. With the use of this preparation even the women whose breasts are totally dry, start milk formation.

xviii) Milk methodically cooked with the decoction of roots of *śāli*, *saṣṭika*, *darbha*, *kuśa*, *gundrā*, *itika*, *sarivā*, *virāṇa*, *ikṣu*, *kuśa* and *kāśa* is a good prescription for the woman who is basically unable to produce milk or for the milk vitiated by evil-eye.

xix) Milk treated with *marica* and *pippalmūla*.

xx) Powdered *māgadhī*, *māgura* and *pathyā* alongwith *ghṛta* mixed with milk.

..... क्रमशः

६. मरीचं पिप्पलीमूलं क्षीरं क्षीरविवृद्धे। मगधी नागरी पथ्या गुडेन सघृतं परः ॥
पातं जनयते क्षीरं स्त्रीणाञ्च क्षीरपादपि ॥ (हो० सं० तु० रसा० ५/३३, ४)

७. शालिषष्टिकगोधूमांसांशुद्रशणानि। कालशाकमलाब् च नारिकेलं कसेरकम् ॥ ११॥
शृङ्गाटकं वरी चापि विदारीकन्दमेव च। लशुनं दुग्धवृद्धे स्त्री सेवेत सुमना भवेत् ॥ १२॥

कलमस्य तण्डुलानां कल्कं वा क्षीरोषितं पिबति। सा भवति पूरां तरुणी क्षीरमाशेच तुङ्गकुचगुला ॥ १३॥
विदारीकन्दस्य रसं विबेत्स्तन्यस्य वृद्धये। तच्चूर्णं तस्य वृद्धयर्थं पिबेद्वा क्षीरार्जुतम् ॥ १५॥

(पा० प्र० पूर्व० ४/११ से १३ व १५)

८. भूमिकृष्णपण्डमूलस्य क्षीरपिष्टस्य यो रसः। पिबेत्स्तन्यकर्तं तस्याः क्षीरं बहु विवर्धते ॥
शालावरी क्षीरपिष्टा पीता स्तन्यविवर्धनी। कवोष्णं कषया पीतं क्षीरं क्षीरविवर्धनम् ॥
वनकापर्शकेशेषूणां मूलं सौवीरकेण वा। विदारीकन्दं सुरया पिबेद्वा स्तन्यवर्धनम् ॥
(चक्रकाष्ठिकम्)

पिप्पली पिप्पलीमूलं चर्व्यं शुण्ठी यवानिका। जीरेके द्वे हरिद्रे द्वे विडं सौवर्चलं तथा ॥
एतैर्वीर्यधैः पिष्टेयानां विपाचयेत्। तद्यथाग्निबलं पीत्वा प्रसूता सुखमश्नुते ॥
आमलाहर्तं वृषं कफघ्नं वातनाशनम्। तद्व्रजकाष्ठिकं नाना स्त्रीणाग्निनिविवर्धनम् ॥
मक्कल्लुलशमनं परं क्षीरविवर्धनम् ॥ (यो० २० क्षीरतोष चि०)

xxi) Grains of specific cereal named *kalama* pestled either with water or milk, if used by the woman, produce so much milk that her breasts become too much erect.

xxii) Juice or powder of *vidārkanda* mixed with milk or expressed juice of *vidārkanda* pestled with milk and mixed with sugar or powder of *vidārkanda* mixed with wine.

xxiii) *śātāwari* pestled with milk.

xxiv) Powdered *kaṇā* with luke-warm milk.

xxv) Powdered roots of *banakārpāsa* and *ikṣu* mixed with *sauwira* (*kāyī*).

xxvi) *Vajrakāyika*—

Powdered *pīppalī*, *pīppalimūla*, *cavya*, *śunghī*, *yāwānikā*, both *jīrakas*, both *haridraś*, *wīd* and *sauwarcala* salts should be cooked with *kāyī* and given to the woman according to her digestive power. This preparation known as *vajrakāyika* cures *ānavāta*, is *vṛjya* (aphrodisiac), suppresses *kapha* and *vāta*, increases appetite, cures *makkalīa śūla* and increases quantity of milk.

विमर्श (Comments)

महर्षि सुश्रुत तथा उनके अनुयायी भवमिश्र ने धातुओं एवं उपधातुओं के क्षयार्ति लक्षणों तथा चिकित्सा के साथ स्तनशय्य के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन कर पुनः स्तन्यनाश के हेतु तथा उसकी चिकित्सा का वर्णन किया है। यह वास्तविकता में पुनर्सक्ति मात्र ही है, परन्तु पुनर्सक्ति में पृथक् वर्णन के कारण यहाँ भी उसका पृथक् निर्देश कर दिया गया है। महर्षि सुश्रुत एवं चाण्ड आदि ने स्तन्य-नाश के हेतु गिनाकर, उसकी चिकित्सा का तथा महर्षि चरक ने सीधे ही क्षीरजनन द्रव्यों या आहार-विहारादि का वर्णन किया है, वस्तुतः दोनों में कोई भेद न होने के कारण सभी का एक साथ ही वर्णन दिया गया है।

Suśruta and Bhāvaprakāśa while describing clinical features and treatment of *kṣaya* (decrease) of various *dhatūs* and *upadhātūs*, have included *stanya* also. In subsequent description clinical features and treatment of *stanyamāśa* have been described. Actually there is no difference in both these conditions, however, since in the classics both have been described separately, hence *stanyakṣaya* and *stanyamāśa* both are recapitulated here also. Suśruta etc. have described the treatment of *stanyamāśa* after elaborating its etiology, drugs prescribed are likely to increase the amount of milk. Caraka has prescribed drugs for the same purpose but without giving the name of disease or its etiology. Since aim of the drugs prescribed by both is identical, hence all the prescriptions have been recapitulated at one place.

स्तन्यवृद्धि (Stanyavardhi or increase in amount of milk)

लक्षण (Clinical features)

स्तन्य स्तनयोरापीनत्वं मुहुर्मुहुः प्रवृत्तिं तोदय ॥ (सु० सं० सू० १५/१६)

स्तन्य की अतिवृद्धि होने से स्तनों में भारीपन, बार-बार (स्तन्य की) प्रवृत्ति तथा (स्तनों में) तोद होता है।

आचार्य भवमिश्र ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं^१।

In case of *stanyavardhi*, the breasts become heavy and painful associated with recurrent flow of milk.

चिकित्सा (Treatment)

तेषां यथारसं संशोधनम् क्षणञ्च क्षयदातिरुद्धैः क्रियाविशेषैः प्रतिकुर्वीत ॥

(सु० सं० सू० १५/१६)

उन सभी (वृद्ध धातुओं, मलों तथा उपधातुओं) में यथावश्यक संशोधन, क्षण (संशोधन), क्षय के अतिरुद्ध (जो वृद्ध धातु आदि का शमन तो करें पर उनके क्षयकारक न हों), क्रियाविशेष अर्थात् संशोधन, संशोधन आहार एवं आचार्य आदि का प्रयोग करें।

आचार्य भवमिश्र ने सीक्षित वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके (वृद्ध धातुओं आदि के) ह्रासकारक आहार-विहारा आदि का सेवन करयें^२।

स्तन्य वृद्धि में मण्ड^३ एवं इक्षु^४ का प्रयोग निषिद्ध है। यह वमन साध्य^५ व्याधि है। निरन्तर स्वाव वाले स्तन्य में निरेचन^६ देना चाहिए।

Appropriate *samsōdhana* (purifying measures), *samsāmana* (suppressive measures), dietetics and other mode of life and drugs which inspite of suppressing the increased *dhatū* do not produce its *kṣaya* (decline) should be used. Use of sugarcane juice and *maṇḍa* (scum of boiled rice) is contraindicated, emesis is beneficial. Purgatives should be given to the woman having continuous flow of milk.

धात्री या माता के स्तन्य के अभाव में अन्य-उपयोगी दुग्ध (Substitute milk in case of non-availability of milk of mother or wet-nurse)

क्षीरसात्यतया क्षीरमाजं गव्यमध्यापि वा। दद्यादास्तन्यपयोभिर्बालानां वीक्ष्य मात्रया ॥

(सु० सं० शा० १०/४८)

स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तदुणं पिबेत्। मूलेः सिद्धं बृहत्याहोः स्थिराभ्यां वा सितायुतम् ॥

(अ० सं० उ० १/३९)

स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तदुणं पिबेत्। ह्रस्वेन पञ्चमूलेन स्थिरया वा सितायुतम् ॥

(अ० ह० उ० १/२०)

१. स्तनयोरापीनत्वं क्षीरत्वान् मुहुर्मुहुः। तोदय तत्र भवति स्तन्याधिभ्यस् लक्षणम् ॥७२॥ (पा० प्र० पूर्व० ७/७२)
२. क्रियाविशेषैरिति क्रिया संशोधनसंशोधनहारवागव्या। (सु० सं० सू० १५/१६ की उद्धृ० टीका)
३. तत्तद्व्यासकाहारादिहरापीधेवणात्। दोषधातुमूलानां हि ह्रासो निमित्ततो नृणां ॥ (पा० प्र० पूर्व० ७/७४)
४.धात्र्याः प्रवृद्धे पयसि.....। मण्डं पिपङ्गोपादिशोद्विग्रीहीत् ॥ (का० सं० कल्प० ७/६७, ६८)
५.पयोऽतिवृद्धौ। इक्षुः प्रयोगो न हितीते। (का० सं० कल्प० ७/१०८, १०९)
६.क्षीरवृद्धिवमनसाध्या इति। (का० सं० सि० ७/३)
७.स्वकक्षीरा.....। (का० सं० सि० ७/५)

(माता या धात्री का स्तन प्राप्त न होने पर) बालक को दुग्ध ही सादन होने के कारण बकरी अथवा गाय का दूध आस्तन्यपथि (जब तक आवश्यकतानुसार स्त्री-स्तन्य की पुनर्पथि न हो जाय अथवा स्तन-पान की योग्यता रहे) तक मात्रा के अनुसार दें।

अष्टाङ्गसंहार ने लिखा है कि स्तन्य के अभाव में बकरी अथवा गाय का दुग्ध, तदनुग अर्थात् धात्री के स्तन्य के सदृश गुणों वाला करके तथा बृहत्पादि वर्ण (बृहती द्रव्य, गोक्षुर, शालपर्णी, पुरिषपर्णी अर्थात् लघुपञ्चमूल) की औषधियों से अथवा दोनों स्थितियों से सिद्ध करके तथा सिला मिश्रित कर के पीने को दें।

अष्टाङ्गहृदयकर ने लिखा है कि स्तन्यभाव में तदनुग अथवा गाय का दूध, लघुपञ्चमूल अथवा स्थिरा से सिद्ध एवं सिला मिश्रित कर पीने को दें।

आचार्य भवमिश्र ने महर्षि सुश्रुत तथा टीकाकार इलहण के मत का ही अनुमोदन किया है।

Susruta says that milk is the only congenial diet to the child, when mother or wet-nurse is unable to feed, goat or cow's milk should be given in appropriate amount. This substitute feed is to be continued until the mother or wet nurse does not regain sufficient milk or else till the child can not thrive properly without milk.

Both the Vagbhata has said that goat or cow's milk should be given to the child making it similar to the mother's milk, after medicating it either with decoction of *laghu-pāñcamūla* or both *sthira*s and mixed with sugar.

विमर्श (Comments)

अज्ञा अथवा गौ के दुग्ध में स्त्री-दुग्ध की अपेक्षा प्रोबूजिन की मात्रा किञ्चित् अधिक तथा शर्करा की कम होती है। साधन-काल में विभिन्न औषधियों के मिश्रण से सम्भवतः गौ या अज्ञा दुग्ध की प्रोबूजिन की मात्रा कुछ कम एवं वह सुपाच्य हो जाती हो, सिला का मिश्रण शर्करा की मात्रा की पूर्ति की दृष्टि से किया गया होगा, अतः महर्षि चाण्ड का वर्णन अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

In comparison to human milk, the milk of cow or goat contains more protein and less carbohydrate (lactose). Treatment of milk, with these drugs might be reducing amount of protein and also converting it to more assimilable form. Mixture of sugar compensates carbohydrate or in other words these alterations will make the milk of cow or goat more similar to human milk.

स्तन्य अपनयन का काल (*Stanya apnayanakāla or weaning period*)

अथैनं जातदशनं क्रमशोऽपनयेत् स्तनात्। पूर्वोक्तं योजयेत् क्षीमन्नं च लघुबृंहणम्॥

(अ० सं० ३० १/५३)

१. स्त्रीस्तन्यभावे च क्षीनतर्ति निर्दिशन्नाह.....। आस्तन्यपथिरेति यावत् स्तन्यस्य पुनः पथिः परि समन्तो भावेन प्रातिर्भवति, अथवा यावत् स्तन्यपानस्य योग्यता लब्धविरहः॥ (सु० सं० शा० १०/४८ की इलह टीका)

२. क्षीरसादन्यतया क्षीरमात्रं गव्यमथानि वा। दद्यादास्तन्यपथिर्वातेभ्यो बौक्ष्य मात्रया॥

क्षीरसादन्यतयेति। यतः स्थितोः क्षीरमेव सादन्यं भवति न त्वनारिकम्। आस्तन्यपथिरेति। यावत् स्थिराः स्तन्यस्य समन्तोभावेन प्रातिर्भवति। अथवा यावत्स्तन्यपानस्य योग्यता पथित्विरहः॥ (पा० प्र० पूर्व० ४/३५ व टीका)

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

अथैनं जातदशनं क्रमशोऽपनयेत् स्तनात्। पूर्वोक्तं योजयेत्क्षीमन्नं च लघु बृंहणम्॥

(अ० ह० ३० १/३८)

अष्टाङ्गसंहार एवं अष्टाङ्गहृदयकर दोनों ने ही लिखा है कि (बालक को) दन्तोत्पत्ति के बाद क्रमशः या धीरे-धीरे स्तन-पान का परित्याग करना चाहिए तथा पूर्वोक्त क्षीर (पूर्ववर्णित अनादि) तथा लघु एवं बृंहण अन्न का सेवन करना चाहिए। टीकाकार इन्द्र ने दन्तोत्पत्ति के पश्चात् अर्थात् एक वर्ष की आयु के पश्चात् स्तन-अपनयन कराने का विधान दिया है।

After eruption of teeth, gradual weaning should be done and child should be given milk of cow or goat described earlier alongwith light and anabolic cereals. Indu says that weaning should be done after one year of age.

स्तन्य-अपनयन-विधि (*Stanya-apnayanana-vithi or method of weaning*)

कुर्वाद्भूतलं स्नेहसंक्रान्त्या स्तनलेपनैः।

(बालक को दूध छुड़ाने के लिए) स्नेह (पुत्र-प्रेम) को धीरे धीरे कम करके, स्तनों में बौभस लेप करके (ताँक बच्चे को घृणा हो जाय) या अलकक आदि लगाकर कृत्रिम क्षत (का रूप एवं रंग) दिखाकर (जिससे बालक स्वयं ही स्तन ग्रहण न करे) स्तनपान (धीरे धीरे) छुड़ाना चाहिए।

Mother should show less affection to the child and make her breasts either hideous by applying loathsome anointments, or with artificial ulcer by applying *alaktaka* (red resin of certain trees, red lac or sap used by the woman to dye soles of feet etc.). Having seen these types of breasts, the child himself will not touch them. Weaning should be gradual.

धात्री की चिकित्सा (*Dhātārcikitsā or treatment of wetnurse*)

माता या धात्री को स्तन अथवा स्तन्यविकार के अतिरिक्त अन्य वही व्याधियाँ होती हैं, जो कि किसी उस आयु की सामान्य स्त्री को हो सकती हैं; सम्भवतः इसी कारण से काश्यपसंहिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुस्तक में इस-प्रकार का वर्णन नहीं मिलता, परन्तु काश्यप संहिता में गुरु-शिष्य परम्परा की प्रज्ञोत्तरी के रूप में^३ बालक के सुख-दुःख धात्री के ही आश्रय होने के कारण, धात्री की चिकित्सा के महत्त्व को दर्शाते हुए इस अध्याय का विशिष्ट उल्लेख हुआ है, अतः यहाँ पर भी इस वर्णन को उद्धृत किया जा रहा है। महर्षि काश्यप ने स्पष्ट किया है कि संसार में वैद्य, धात्री एवं बालक तीन ही ऐसे हैं जिन्हें अत्यधिक दुष्कर कार्यों को करना होता है, ये ही सुखी एवं दुःखी भी होते हैं।

Except the diseases of breasts and milk, there are no other diseases which afflict exclusively mother or wet nurse. Probably due to this reason, the authors (except Kāśyapa) have not prescribed even a single recipe for any of their disorder. However, Kāśyapa says that all the pleasures and sorrows of the child depend upon the wet-nurse, hence, her proper

१. अथवर्धनन्तरं जातदशनं बालं। (अ० सं० ३० १/५३ की इन्द्र टीका)

२. अथतो धात्रीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। इति ह स्माह भगवान् काश्यपः।

धात्रीचिकित्सां निखिलां वक्तुमर्हसि मे मुने। सुखं दुःखं हि बालानां धात्रीलुप्तमसंशयम्॥

इति पृष्ठः स शिष्येण स्थविरिण महांतायः। धात्रीचिकित्सितं कृत्स्नं प्रोवाच वक्तां वरः॥ (का० सं० वि० १८१ से ४)

३. वृद्धजीवक ! लोकेऽस्मिन्स्यो दुष्करकारिणः। भियमधात्री च बालश्च त एव सुखदुःखिताः॥ (का० सं० वि० १८५८)

treatment is most essential, and has attributed one full chapter named "Dhātārcikitsā" for the purpose, in which dietetics, mode of life and drugs for wet-nurse have been mentioned. In his opinion, in whole world the physician, the wet-nurse and the child had to perform most difficult tasks, thus only these three are afflicted by sorrows and happiness or are much more vulnerable to be seized with pain or pleasure. The description of Kāśyapa is being recapitulated here.

धत्री का महत्त्व (Importance of dhātā or wet-nurse)

धत्री पुत्रशरीरार्थं स्वशरीरोपशोषणम् । स्नेहात् प्राप्नोति सुबहुन क्लेशांश्चायान् सुदारुणान् ॥
आशास्नेहकृपाधर्माद्रक्षणार्थं च मातरः । सहने सर्वदुःखानि मानिनी चात्र कील्यते ॥
गर्भात् प्रभृति बालोऽपि । अधिकं पीडयते दुःखैर्कुर्वन्नपि तत् स्वयम् ॥
तस्माच्च धत्री सततं शुभचोष्टाऽशनीस्थितिः । माता भवति पुत्राणां भुक्ते पुत्रफलानि च ॥

(का० सं० चि० १८/६३-६५)

धत्री स्नेहवश पुत्र-शरीर के लिए (पुत्र के पालन एवं संवर्धन के लिए) अपने शरीर का शोषण तथा अनेकानेक दारुण क्लेशों को प्राप्त करती है । मातायें आशा (पुत्र से भावी जीवन में अनेकों आशाओं), स्नेह, कृपा, धर्म (पुत्र-पालन रूपी धर्म) तथा बालक की रक्षा के लिए अनेकों दुःखों को सहन करती हैं तथा इसमें वे अपने मान (गौरव) का अनुभव करती हैं । गर्भ से लेकर बालक भी (अपने कष्टों आदि का) स्वयं प्रतिकार (तथा इच्छाओं की पूर्ति) न कर सकने के कारण अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित होता है । धत्री पुत्र के लिए निरन्तर शुभ चोष्टाओं एवं आहार-व्यवस्था करने के कारण उसकी माता रूप होकर पुत्र-फल का उपभोग करती है ।

The wet-nurse nurtures the child out of sheer affection and during this process gets herself deprived of nourishment or gets emaciated and also tolerates various troubles. The mothers withstand troubles due to hope (for future protection to be offered by the child), affection, compassion, duty and protection of the child; and by this they feel proud or honoured. The child, also, since intra-uterine life suffers various pains because of inability to defend oneself and fulfill own requirements. The wet-nurse by her auspicious/beneficial acts and management of diet for the child becomes a foster mother, thus enjoys the fruits of having a son.

धत्री की उम्रिन का वर्णन (Description of agni or digestive capacity of wet-nurse)

..... .. ॥

..... (पु)ष्टिकी धत्री तीक्ष्णानिर्वर्तयैतिकी । समधातुः समानितु विषयैर्विषयानिकी ॥

आयुशरोर्ययोर्मूलं प्रज्ञानं च समानित्वा । विषयः सर्वरोमाणां मूलं ह्यस्य ॥

(का० सं० चि० १८/५६)

जिस धत्री को ऋक्षसाव (विषय पूर्वक) हो रहा हो तथा बात एवं पित्त का प्राधान्य हो, वह धत्री तीक्ष्णानि वाली होती है । समधातु धत्री (जिसके वातादि तीनों समवाय में हों वह) समानित तथा विषय धातु वाली विषयानि वाली है ।

सम अग्नि की धत्री प्रजा अर्थात् सत्तति के आयु एवं आरोप्य की आधार तथा विषयानि वाली सभी रोगों की मूल तथा ह्रास (शरीर के) का कारण है ।

The wet-nurse having regular menstruation and dominance of vāta and pitta possesses *tikṣṇāgni* (strong digestive capacity). The wet-nurse having *samadhānu* (all the three *dōṣas* in equilibrium) has *samāgni* (normal digestive capacity) and having *viṣṇa dhānu* (unequal amount of *dōṣas*) possesses *viṣṇāgni* (irregular digestive power).

Samāgni is the basis of health and longevity of the child, while *viṣṇāgni* is the root cause of various diseases and also of decline or loss of health.

धत्री के अग्नि-विकार की चिकित्सा (Treatment of abnormalities of agni or digestive capacity of wet nurse)

तीक्ष्णस्य बृंहणं नित्यं मन्दानोदीपनक्रिया । पथ्याशनं तु सततं विषयानेः सुखान्वहम् ॥
कल्याणकं षट्पलं वा प्रयोगेनोपयुज्यते । यथावत् यथायोगं पञ्चक ॥
..... .. ॥

(का० सं० चि० १८/७-९)

(इस वर्णन में 'तीक्ष्ण अग्नि वाले' अर्थात् पुष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरुष को सामान्य मानव मात्र का उपलक्षण मानकर तथा इस विवरण का उल्लेख धात्रीचिकित्सा अध्याय में ही होने के कारण विषय यहाँ उद्धृत किया जा रहा है) । तीक्ष्णानि में सदा बृंहण, मन्दानि में दीपन क्रिया तथा विषयानि में पथ्य भोजन सुख को लाने वाले होते हैं । इसमें कल्याणक अथवा षट्पल घृत का उपयोग करना चाहिए तथा कलाबल को देखकर आशयकानुसार पञ्चकर्म करना चाहिए ।

In *tikṣṇāgni* (strong digestive fire) the *vyāhāna karma* (anabolic substances), in *mandāgni* (less digestive fire) *dīpana kriyā* (appetizing substances) and in *viṣṇāgni* (irregular digestive fire) congenial diet always gives relief. *Kalyāṇaka ghṛta* and *ṣṭṭpala ghṛta* should also be used, considering strength and energy *pāṇcakarma* can be used as and when needed.

धत्री की अजीर्ण जन्य व्याधियाँ (Diseases caused by *ajīrṇa* or indigestion to a wet-nurse)

अजीर्णं चापि धत्रीणां नित्यमेव न शस्यते । अजीर्णदूषि (ता दोषा धत्रीणां जनयन्ति हि) ।

..... (५) रुचिनाग्निमदमोहविचर्चिकाः । पापाकुष्ठालजीगुल्महृद्रोगश्वासकासकाः ।

हिक्कातन्द्राश्रमश्वासच्छर्दोपसमारविग्रहाः ॥

रक्तपित्तभ्रमोन्मादशूलशोषणलग्रहाः । उरुस्तम्भः ससंन्यासस्तथाऽन्ये च महानदाः ॥

(का० सं० चि० १८/५४-५६)

धत्री को अजीर्ण होना उचित नहीं है । अजीर्ण के कारण दूषित या प्रकुपित दोष धत्री को अस्ति, गलति, मद, मोह, विचर्चिका, पापा, कुष्ठ, अलजी, गुल्म, हृद्रोग, श्वास, कास, हिक्का, तन्द्रा, श्रमश्वास (परिश्रम करने में श्वासकष्ट), छर्दि, अपसमार, ग्रहबाधा, रक्तपित्त, भ्रम, उन्माद, शूल, शोष, गलाह्र, उरुस्तम्भ, संन्यास तथा अन्य भी बहुत से भ्रंशक रोग उत्पन्न कर देते हैं ।

Ajīrṇa (indigestion) to a wet-nurse is not proper, because the *dōṣas* vitiated or aggrivated due to *ajīrṇa* produce *aruci* (anorexia), *glāni* (lassitude), *māda* (intoxication), *moha* (unconsciousness), *vicarcikā*, *pāpā*, *kusṭha* and *alajī* (all skin disorders), *gulma*, *hydroga* (cardiac disorders), *śvāśāśwāsa* (exertional dyspnoea), *charṭi* (vomiting), *apasmāra* (epilepsy), *grahabādha* (acute infective disorders), *raktapitta* (bleeding diathesis), *bhramā* (giddiness), *unmāda* (insanity), *śūla* (colic), *śoṣa* (emaciation), *galagraha* (stiffness of neck),

urastanbha (stiffness of muscles of thighs), *sanjyēsa* (coma) and many serious disorders to the wet-nurse.

धानी को परिमित आहार करने का निर्देश (*Advice to a wet-nurse to consume limited diet and its benefits*)

मितप्रथाशानामातुः पुत्रे तेषामसंभवः । सुखेदयश्च धानीणां तस्मात्तदुपपादयेत् ॥ (का० सं० चि० १८/५७)

परिमित तथा पथ्य आहार करने वाली माता के पुत्र को ये (उपर्युक्त) व्याधियाँ नहीं होतीं तथा धानियों को भी सुख (शारीरिक एवं मानसिक प्रसन्नता) की प्राप्ति होती है अतः इनको (मित एवं पथ्य आहार का) सेवन करना चाहिए ।

The mother/wet-nurse who consumes limited and congenial diet, her child does not suffer from above disorders and she herself also gets physical/psychological pleasure, thus she should always use congenial and limited diet.

विमर्श (Comments)

अजीर्ण से उत्पन्न होने वाली उपर्युक्त वर्णित व्याधियाँ धानी के ही साथ पुत्र को भी हो जाती हैं । इस कथन की पुष्टि "पुत्र को ये व्याधियाँ नहीं होतीं" इस वाक्य से हो जाती है ।

Above saying that the "child dose not suffer" indicates that the diseases caused by indigestion afflict wet-nurse and child both.

धानी की निर्यचर्या (*Daily routine of wet-nurse*)

प्रक्षणेर्ननानं शुक्लाम्बरनिवेद्यम् । मृष्टमन्नं सुखा ॥
..... ॥ ॥ (ध) परित्याग्नीणां सुखहेतवः ॥

(का० सं० चि० १८/११,१२)

अभ्यङ्ग, उदरर्शन, स्नान, श्वेत (स्वच्छ) वस्त्रों का धारण तथा शुद्ध-भवित्र अन्न का भोजन आदि धानी के धर्म, रति (संभोग अथवा मानसिक सुख एवं शान्ति) तथा सुख के कारण हैं ।

स्वस्थ अथवा रम्य किसी भी धानी को विशेषकर शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए । शीतल जल विपाक में मग्न होने के कारण पित्तजन होता है ।

Massage, use of unguents, bath, white garments and clean and pure food produce virtue, satisfaction and happiness to the wet-nurse. Healthy as well as diseased wet-nurse should use cold water. Cold water being *madhura* (sweet) in *vipāka* suppresses *pitta*.

धानी को क्षार-प्रधान औषधि के प्रयोग का निषेध (*Contraindication for use of kṣāra by wet-nurse*)

न तूपयजेयेत् क्षारं क्षारप्रायौषधानि वा । प्रजाविनाशनः क्षारो धानीणां स न शस्यते ॥

(का० सं० चि० १८/१०)

(धानी-चिकित्सा में) क्षार अथवा क्षार-प्रधान औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि सन्तान-नाशक होने के कारण धानियों के लिए यह प्रशस्त नहीं माना गया है ।

१. धानीणां च विशेषेण स्वस्थानां रोगिणामपि । पूर्वोक्तगुणबाहुल्यात् प्रानीयं सेव्यमिष्यते ।
विपाके मग्नं शैत्याद्वापि पित्तजन्युच्यते ॥ (का० सं० चि० २३/१८,१९)

Kṣāras or the drugs having predominance of *kṣāra* should not be prescribed to the wet-nurse, because these are harmful to the child.

धानी के मेदरोग की चिकित्सा (*Treatment of medo-rogā or obesity of wet-nurse*)

मेदस्विनीनां धानीणां सिराकर्म प्रशस्यते । स्नेहस्वेदोपपन्नानामूर्ध्वं चायश्च शोथनम् ॥
ततः सा मेदसि क्षीणे स्रोतःसु विवृतेषु च । ॥

..... ॥ ॥ यो रसः ॥ (का० सं० चि० १८/१३,१४)

मेदस्वी धानियों के लिए सिराकर्म प्रशस्त माना गया है (अर्थात् मेदरोग पीड़ित धानी का सिरावेध करना चाहिए) । स्नेहन तथा स्वेदन कारक ऊर्ध्व तथा अधःशोथन (वमन एवं निचेचन) कराना चाहिए । इससे वह मेद के क्षीण हो जाने से स्रोतों के खुल जाने के कारण.....(स्वस्थ हो जाती है) ।

Venesecution is beneficial in obesity of wet-nurse. After giving oleation and sudation, emetics and purgatives should be prescribed. With these measures her fat decreases thus *srotasas* open-up and she attains normal health.

धानी की कृशता एवं अनर्तव्य की चिकित्सा (*Treatment of emaciation and amenorrhoea of wet-nurse*)

कृशां च नष्टपुष्पां च बृंहयेतेन सिद्ध्यति । (का० सं० चि० १८/१४)

कृश तथा नष्टपुष्पा धानी को बृंहण करने से सफलता मिलती है ।

To a emaciated and amenorrhoeic wet-nurse *vyāghraṇa* (anabolic) treatment should be prescribed.

बला तैल (*Bala taila*)

सभी आचार्यों ने मूढ़ गर्भ के निकलने के पश्चात् की चिकित्सा में बलातैल का वर्णन किया है (पृष्ठ ५३४ से ५३७) । बला के अतिरिक्त अन्य घटकों में महर्षि काश्यप तथा अन्य आचार्यों में पूर्णतया मतवैभिन्य है । यद्यपि यह बला-तैल अनेकों व्याधियों में उपयोगी है परन्तु धानी-चिकित्सान्तर्गत वर्णित होने से यहाँ उद्धृत किया जा रहा है ।

Though *balatila* has already been described in eighth chapter, for the management after extraction of *mūdhagarbha*, however, since in this description except *balā* all other ingredients are entirely different, and has been indicated for treatment of wet-nurse, hence is being recapitulated here.

(अ) बलातैल निर्माण-विधि (*Method of preparation of balā-taila*)

बलामूलतुला धौता दशमूलं शतावरी । गुडूची रोहिषं रास्ना वृश्चिकाली पुनर्नवा ॥
वृषः सहचरोशरसामिवापूर्वं च ॥

..... ॥ काकजङ्घांशुप्रतप्ये । अक्षगन्ध मूर्धन्यः कालाऽथ नवमालिका ॥
अतिमुक्तकाशैर्घृण्णकपित्तं त्रिफलेति च । दशमूलान् प्रपुत्यते भागा दशपलाः स्मृताः ॥

यवाः कुलत्था माषाश्च ॥ ॥

..... ॥ (जल) श्रेणे चतुर्भागावशोषिते । तं कषायं परिचाय्य पुनरनावाधिश्रयेत् ॥
अथेमात्पौषधन्व्यर पातिकाति निघापयेत् । द्वे मेदे द्वे हरिद्रे च काकोत्पौ वृषजीवकौ ॥

माषपर्णी | ॥
 लवसत्रवन्दनोशीरं द्वै बले लवणद्वयम् । पूर्वा श्वदंष्ट्रा शाङ्गेष्ट्रा श्यामा द्राक्षा सुरोहिणी ॥
 मधुकं हस्तिपिपल्यः कुष्ठं व्याघ्रनखं चत्वा । सुक्ष्मैलागुत्तकाण्यमः शतपुष्पा परुषकम् ॥
 | नि च ॥
 शंखपुष्पी विशल्या च वृश्चिकाली मथूलिका । दाडिमाणि चाप्लाणि गुग्गुल्वादि सुगन्धि च ॥
 अक्षोटं पनसं भय्यं प्राचीनामलकानि च । शतावरी विदारो च मधुपर्णी विषा (पिका) ।
 (क) प्रायशार्ढकं भवेत् ॥
 लवङ्गपुष्पं कर्पूरं सूचकाऽथ कटुकाफलम् । आढकं तिलतैलस्य क्षीरोद्रेणं च पाचयेत् ॥
 तत् सिद्धं प्रतिसंहत्य बलातैलं निधाययेत् । घृतभाण्डे दृढे दाले ॥
 | सां प्रक्षणेपु (प्र)शस्यते ॥
 (का० सं० चि० १८/१५-३०)

घोकर स्वच्छ को हुई बलामूल १ तुला (१०० पल), दशमूल, शतावरी, गुडची, रोहिष (तुण), रास्ना, वृश्चिकाली, पुनर्नवा, वृष, सहचर, उशीर, सारिवा, मूर्वा, (चव्य),काकजंघा, अंशुमती, अश्वगन्धा, मृगवीर, काला, नवमालिका, अतिमुक्तक, शाङ्गेष्ट्रा, कीरत्य तथा त्रिफला तै। दशमूल से लेकर (त्रिफला तक) सभी द्रव्य समभाग में मिलाकर दस पल; यव, कुलथ एवं माष तथा जल एक द्रोण (४ आढक) लेकर पकायें, चतुर्थ भाग अवशेष रहने पर इस कषाय को छानकर पुनः आग पर रख दें, अब इसमें दोनों मेरा, दोनों हरिद्रा, दोनों काकोली, वृष, जीवक, माषपर्णी त्वक्, पत्र, चन्दन, उशीर, दोनों बला, दोनों लवण (सैन्धव तथा सौवर्चल), मूर्वा, श्वदंष्ट्रा शाङ्गेष्ट्रा, श्यामा, द्राक्षा, रोहिणी, मधुक, हस्तिपिपली, कुष्ठ, व्याघ्रनख, चत्वा, सूक्ष्मैला, अमृत, काशमरी, शतपुष्पा, परुषक,शंखपुष्पी, विशल्या, वृश्चिकाली, मथूलिका, दाडिम आदि अन्त द्रव्य, गुग्गुलु आदि सुगन्धि द्रव्य, अक्षोट, पनस, भय्य, पुरने आमलक, शतावरी, विदारो, मधुपर्णी, विषाणिका सभी एक एक पल की मात्रा में डालकर पकायें । जब वह कषाय आधा आढक बच जाय, तब इसमें लवङ्गपुष्प, कर्पूर, सूचका, कटुकाफल (आदि का चूर्ण) एवं एक आढक तिलतैल तथा एक द्रोण (चार आढक) दुग्ध डालकर पकायें । इस बला तैल के सिद्ध हो जाने पर इसे हस्तिदन्त निर्मित, सुदृढ़ घृतभाण्ड में भर कर भली भाँति बौध कर रख दें । यहअप्यङ्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है ।

Properly cleaned (by washing) root of *balā* one *tula*, *dāśamūla*, *śatāvārī*, *guḍācī*, *rohīṣa* (*trpa*), *rāśnā*, *vṛścikāḥ*, *pañamavā*, *vṛṣa*, *śahacārā*, *uśīrā*, *sāriṣā*, *mūrvā*, *kalā*, *navamālīkā*, *atimuktaka*, *kākaṅgāṅghā*, *aṁśumātī* *aśvagandhā*, *mṛgāivārā*, *kāḍā*, *navamālīkā*, *atimuktaka*, *śāṅgeṣṭrā*, *kāpithā* and *triphalā* all in equal quantity together ten *pala* and *yava*, *kuḍāthā* and *māṣa*-should be boiled with one *droṇa* (four *āḍhaka*) water. When one-fourth (one *āḍhaka*) remains, it should be strained and again put over the fire. Now in this filtrate both *bālā*, both *haritāḍā*, both *kākolī*, *vṛṣa*, *jīvaka*, *māṣaparnī*, *ivak*, *pāra*, *candana*, *uśīrā*, *mēdā*, both *haritāḍā*, both *kākolī*, *vṛṣa*, *jīvaka*, *māṣaparnī*, *ivak*, *pāra*, *candana*, *uśīrā*, both *bālā*, both *salis* (rock salt and common salt), *mūrvā*, *śvadamāṣṭrā*, *śāṅgeṣṭrā*, *śyānā*, *drākṣā*, *rohīṇī*, *madhuka*, *hastipipalī*, *kuṣṭhā*, *vyāghraṇakhā*, *vaccā*, small *elā*, *agurā*, *kāśmārī*, *śatapusṭpā*, *pārīśāḍka*,*śāṅhapuṣṭpī*, *viśālīyā*, *vṛścikāḥ*, *madhūlīkā*, *dāḍīmā* etc. *sour drugs*, *gugūlū* etc. aromatic drugs, *akṣojā*, *pamasa*, *bhavya*, old (dried) *āmalaka*, *śatāvārī*, *vidārī*, *madhuparnī* and *viśāṇīkā* etc. each drug in the amount of one *pala* should be mixed and boiled, till only half *āḍhaka* decoction remains. In this decoction powdered *lavāṅgāṅghā*, *karpurā*, *sprīkṣā* and *katukāphala* etc. drugs, oil of *tula* one *āḍhaka* and milk four *āḍhakas* should be mixed and oil prepared with standard procedure. When

this *balāvalā* is properly prepared, it should be stored in a strong ivory pot previously used for storing *ghṛta* and mouth of the pot should be properly wrapped and secured. This oil is very good for massage.

(आ) बलातैल-उपयोग (Action and uses of *balāvalā*)

शङ्खगतं कोष्ठातमस्थिमज्जसिरागतम् । बहिराभ्यन्तरागामं हनुस्तम्भं शिरोभ्रम् ॥

एकपक्षबधं शोषस्तानाकटितगुत्तिभ्रम् । बधिरं वेप (मानं च) ॥

..... (५) प्रसारमुन्मादं कटपूतनाम् (कटिवेदनाम्-शु० पा०) ।

कण्ठशूलं शिरःशूलं बध्नं मारतकुण्डलम् ।

अशीतिं वातिकान् रोगान् योनिदोषाश्च विशतिम् । रेतोदोषान् ग्रहान् सर्वान् बलातैलमपेहेति ॥

वृद्ध्या | ॥

..... च्चे जीर्णे तृतीयकचतुर्थके । नारीणां दुष्प्राजातानां योनिशूले श्रमेयु च ॥

नानातिसारचरयोः कफरोगेषु सर्वशः । नाजीर्णकृशमूर्च्छासु न च्छर्द्या च प्रयोजयेत् ॥

(का० सं० चि० १८/३१-३७)

यह बला तैल शाखा, कोष्ठ, अस्थि, मज्जा या सिरा की व्याधियों, बहिरागाम, अन्तरागाम, हनुस्तम्भ, शिरोभ्रम, एक-पक्षबध, शोष, म्लानक (क्षय), अर्दित, गुल्म, बधिरता, वेपन (कम्पन), अपस्मर, उन्माद, कटिवेदना (कटपूतना एक बलाग्रह है, यहाँ वेदनाओं का सन्दर्भ होने के कारण पाठशेष किया गया है), कण्ठशूल, शिरःशूल, बन्ध (आन्वृद्धि), वातकुण्डलिका, वात के अस्सी विकार, योनि के बीसों विकार, शुक्रदोष तथा सम्पूर्ण ग्रहणों को नष्ट करता है । इसके अतिरिक्त वृद्धि, जीर्ण च्चर, तृतीयक तथा चतुर्थक च्चर, दुष्प्राजाता स्त्रियों के योनिशूल एवं भ्रम (क्षकान) तथा अनेकों प्रकार के अतिसार, च्चर तथा सभी प्रकार के कफरोगों में इसका प्रयोग करना चाहिए । अजीर्ण, कृशता, मूर्च्छा तथा छर्दि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

This *balāvalā* cures the disorders of *śākhā* (extremities), *koṣṭhā* (abdomen), *asthi* (bones), *majjā* (bone marrow) and *sirā* (veins), and also cures *bahirāgāma* (opisthotonos), *antarāgāma* (emprosthotonos), *hanustambha* (lock-jaw), *śirobhrāma* (giddiness), *ekapakṣabhadha* (hemiplegia), *śoṣa* (emaciation), *mānāka* (wasting), *ardita* (facial paralysis), *gulma*, *bādhīrya* (deafness), *vepna* (tremors), *apasmāra* (epilepsy), *unmāda* (insanity), *kativēdanā* (pain in sacral region), *karpasāḥ* (carache), *śirośūla* (headache), *bradhna* (hernia), *vātakunḍalikā* (retention of urine due to obstruction in the passage), eighty disorders of *vīṭa*, twenty *yoniṅvāpad* (gynec. disorders), *śukra doṣas* (seminal disc.) and all the *grāha* disorders. This should also be used in *vṛddhī* (hernias), chronic fever, *trīryaka* and *caturthaka* fever (ertain and quartan fevers), vaginal pain of the woman having undergone abnormal labour, *śrama* (tiredness), different types of *atisāra* (diarrhoea) and fevers, and all types of *kapha* disorders.

It is contraindicated in *gūṛṇya* (indigestion), *kṛśatā* (emaciation), *mūrchā* (unconsciousness) and *chardi* (vomiting).

अन्य तैल (Other oils)

(१) रास्नातैल (*Rāśnāvalā*)

एतैरेव विधानेन रास्नातैलं विपाचयेत् । निहन्ति रोगान् मृदुषं य एते परिकीर्तितः ॥

(का० सं० चि० १८/३८)

(बलतैल की) उपर्युक्त विधि से ही रातना का तैल पकाना चाहिए, यह भी उपर्युक्त रोगों का नाशक है।

The *rāṣṇatāila* should also be prepared just like *balatāila*. this oil cures all the diseases indicated under *balatāila*.

(२) शतावरी आदि अन्य द्रव्य-निर्मित तैल (*Oils of śatāwarī etc. other drugs*)

शतावर्या बदर्याश्च गुड्ड्या मधुकस्य च। पुनर्नवाया द्राक्षायाः पीतो सहचरस्य च ॥

वृषस्य नागवीर्याया अनन्ताशतपुष्पयोः। स्नानापाकतैलानामेष एव (विधिः स्मृतः) ॥

..... तं पक्वं तैले सहाचरे। दद्यान्निर्मध्य सततमेतदत्र विशेषणम् ॥

(का० सं० चि० १८/३९-४१)

इसी प्रकार अपने-अपने नाम के अनुसार शतावरी, बदरी, गुडूची, मधुक, पुनर्नवा, द्राक्षा, पीतु, सहचर, वृष, नागवीर्या, अनन्ता तथा शतपुष्पा आदि के तैल की भी यही पाक-विधि है।

यद्यपि सहचर का भी इसी भाँति तैल निर्माण किया जाता है परन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसे पानी में मथकर (तैल में) डाला जाता है।

Oils with *śatāwarī*, *badarī*, *gūḍūcī*, *madhuka*, *punarṇavā*, *dṛākṣā*, *pīṭa*, *śahacara*, *vṛṣa*, *nāgavīrya*, *ananta*, and *śatapuṣpa* should also be prepared with similar procedure and be named according to the principal drug.

Though *śahacaratāila* is also prepared with the same procedure, however, the decoction of *śahacara* is churned before mixing with oil.

(३) श्योनाक तैल (*Śyonāka tāila*)

श्योनाकतैलस्य विधिः स एव परिकीर्तितः। कषाये मधुमांसस्य दद्यात् विशलपत्नानि तु ॥

(का० सं० चि० १८/४२)

श्योनाक तैल की भी यही पाक-विधि है, परन्तु इसके कषाय में मधुमांस^१ ३० पल की मात्रा में डालना चाहिए। Oil with *śyonāka* should also be prepared with identical method, however, *madhumāṃsa* (?) in the amount of thirty *pala* is to be added in this.

(४) कपित्थ तैल-निर्माण-विधि एवं प्रयोग (*Method of preparation and uses of kapithatāila*)

कपित्थतैलस्य विधिः स एव परिकीर्तितः। कपित्थानां तु पक्वानां तुलां दद्यात् स..... ॥

योनिनासपुच्छश्रोत्रदीर्गमस्ये पिच्छलेषु च। कपित्थतैलं पितृभिर्भार्ययेदुः संदा क्रियः ॥

(का० सं० चि० १८/४३, ४८)

कपित्थ तैल की भी यही निर्माण-विधि है, पके हुए कपित्थ (के गूदे) को एक तुला लेना चाहिए।

स्त्रियों की योनि, नासिका, मुख तथा कर्ण की दुर्गन्धि एवं पिच्छिलता में कपित्थतैल की पितृ का सदैव धारण करना चाहिए।

१. मधु या मद्य का तैल-पाक में प्रयोग नहीं होता। मांस का भी प्रयोग आंग्रिक सा है, क्योंकि यह काष्ठोषधियों से निर्मित तैल का वर्णन है। विभिन्न मांसों से निर्मित तैलों का वर्णन आगे दिया गया है। मधुमांस शब्द एकवचन में प्रयुक्त है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ही द्रव्य है, परन्तु यह द्रव्य क्या है? कह सकना संभव नहीं।

With one *hūla* pulp of ripe fruit of *kapitha*, the oil should be prepared as per procedure described earlier.

Tampon soaked with this oil should be used in foul smell and unctuousness of vagina, nose, mouth and ear.

(५) अन्य तैल (*Other oils*)

..... देव प्रकीर्तितम्। केवलं स्वरस्यात्र दद्यात्तैलाच्चतुर्गुणम् ॥

(द्रव्य-नाम खण्डित हैं) की भी यही विधि है, (भेद इतना है कि) केवल स्वरस की मात्रा तैल से चतुर्गुण ली जाती है।

(Names of drugs are missing in the text). The oils with other drugs should also be prepared in the same way, however, juice of drugs should be four times to the oil.

(६) मीनतैल की निर्माण-विधि एवं उपयोगिता (*Preparation and uses of mīnatāila or the oil prepared with fish*)

मीनतैलं च मीनानां कषायेण रसेन च। पक्वं बलतैलमिव तातव्याधिषु शस्यते ॥

(का० सं० चि० १८/४५)

मत्स्य के कषाय तथा रस के बला तैल की ही भाँति पाक करके (मीनतैल का) निर्माण किया जाता है यह बात-व्याधियों के लिए प्रशस्त है।

Just like *balatāila*, the oil is also prepared with decoction and juice of fish. This is beneficial for disorders of *vāta*

(७) बलाकादि तैल-निर्माण-विधि एवं प्रयोग (*Preparation and uses of balākā etc. oils*)

बलाकाहंसवल्गूनां कौञ्जसारसयोगे। आट्टशिकुनकानां च तैलान्याहुः स्वनामभिः ॥

..... (दौर्गन्ध्यानां) विधानं कीर्तितं पुण्यं षण्ढव्याप्रजाकरम् ॥

(का० सं० चि० १८/४६, ४७)

अपने अपने नाम के अनुसार बलाका (बगुला विशेष), हंस, वल्गु, कौंच, सारस, आटी आदि शिकुन (पक्षियों) का भी तैल निर्माण करना चाहिये।

ये दुर्गन्धि को नष्ट करते हैं। षण्ढ तथा बन्ध्या स्त्री को पुत्रोत्पत्ति एवं पुण्य प्राप्ति के लिए इनका विधान किया गया है।

Oils with decoction or juice of meat of *balākā* (a kind of heron), *hamsa* (swan), *valguā* (a kind of heron), *krauñca* (a kind of curlew or osprey), *sārasa* (indian crane) and *āṭī* (a kind of heron or *Turdus gingindanus*) etc. birds should be prepared and named accordingly.

१. वल्गु नाम का कोई पक्षी शब्दकोषों या अन्य वर्णनों में उपलब्ध नहीं है; वरन् वल्गल (चमगादड़) नाम का एक स्थलचर पक्षी होता है। संदर्भ में 'वल्गु' के अतिरिक्त सभी जलचर पक्षी हैं, अतः 'वल्गु' से लेखक का अभिप्रेत पक्षी समझना कठिन है।

These oils cure foul smell and are prescribed for achievement of conception to a *sasāhī* (amenorrhoeic) and *wandhyā* (infertile woman) and are pious.

(१) सहकारादि अन्य तैल (*Sahakāra etc. other oils*)

सहकारसेनापि तद्वतैल प्रशस्यते । विविधानां च तैलानां हृद्या ॥

..... चानि निषेवणम् ॥ (का० सं० चि० १८/४९)

सहकार (अम) के रस से भी इसी प्रकार तैल बनाया जाता है । इसी प्रकार अनेकों प्रकार के हृदय को अच्छे लगने वाले द्रव्यों से तैल का निर्माण कर प्रयोग करना चाहिए ।

Oil can also be prepared with juice of *vahakāra* (mango-fruit) and other *hīrdya* (de-sired) drugs.

धत्री के मिथ्याहार जन्य षष्ठी रोग (*Sasāhi disease caused by abnormal dietetics of wet-nurse*)

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धातृणां शेषकर्म यत् । स्नेहपानात् प्रसूतानां षष्ठीमन्त्रकभक्षणात् ॥
अतिमात्राशनाद्यैक विरुद्धार्जोभोजनान् । धात्रिग्रहः कुमाराणां जायते देहनाशनः ॥
असाध्यश्चानुष (ही च) (मिता) ह्येता धर्मशीला तपस्विनी ॥
जीर्णाशिनो च सततं षष्ठीमतिरत्नसौ । प्रासादां वञ्चनायां च पञ्चकर्मणि कारयेत् ॥
अथवा तपसोरेण शिवं स्कन्दं च तोषयेत् ॥ (का० सं० चि० १८/५०-५३)

अब इसके पश्चात् मैं धात्रियों के लिए शेष कर्मों का वर्णन करूँगा ।

प्रसूत के द्वारा स्नेहपान, षष्ठी (चावल), मन्त्रक (एक प्रकार की मछली) के प्रयोग अथवा अत्यधिक मात्रा में खाने तथा विरुद्ध एवं अजीर्णकारक भोजन करने से कुमारों को देहनाशक षष्ठी रोग हो जाता है । यह रोग असाध्य एवं अनुषङ्गी (दीर्घकाल तक लगा रहने वाला) होता है । मित आहार करने वाली, धर्मपरायण, तपस्विनी, सदैव ही (पूर्व) भोजन के जीर्ण हो जाने पर भोजन करने वाली (स्त्री) इस षष्ठी रोग को पार कर जाती है अर्थात् इस ग्रह से प्रभावित नहीं होती । यदि धात्री षष्ठी से आक्रान्त हो ही जाए तो पञ्चकर्म करना चाहिए अथवा उग्र तपस्या के द्वारा भगवान् शिव तथा स्कन्द को सन्तुष्ट करना चाहिए ।

When puerperal women drink oleaginous substances, eat *sasāhi* (rice) and *mallaika* (a kind of fish), over eat, consume incompatible foods or foods producing indigestion, then their sons suffer from fatal *sasāhi* disorder. This disease is incurable and has tendency of chronicity. The woman who consumes measured amount of food, is virtuous, ascetic and always eats when previous meal is digested, never gets afflicted with *sasāhi*, however, if at all she gets afflicted by *sasāhi*, then *pañcākarma* should be done and lord Śiva and Skanda should be pleased by severe penance.

विमर्श (Comments)

भोजन आदि अपथ्य के सेवन से धात्री का सत्य षष्ठी ग्रह से दूषित होकर, पान करने वाले शिशु को आक्रान्त करता है पर धात्री-शरीर में प्रविष्ट होते हुए भी यह षष्ठी उसे कोई कष्ट नहीं पहुँचाती ।

Due to use of non-congenial diet etc. mentioned above, the milk of wet-nurse gets afflicted with *sasāhi gṛaha* and attacks the suckling child. Though *sasāhi* initially enters the body of wet-nurse, yet does not cause any trouble to her.

धात्री की प्रकृति, प्रजा या सत्य की मात्रा का शिशु पर प्रभाव (*Effect of prakṛti, purity or amount of milk of wet-nurse on the child*)

पित्तानिलप्रकृतिकी पटुक्षीरा पटुप्रजा । कुतः (ततः शु० पा०) पटुजुगडा मूका विदोष क्षीरभोजिनः ॥

(का० सं० चि० १७/५)

पित्त एवं वात प्रकृति, अर्थात् सत्य या लवण रस युक्त सत्य तथा अत्यधिक सन्तानों वाली धात्री का अथवा विदोष-दूषित सत्य-पान करने से बालक पटु, जड़ या मूक हो जाता है ।

The child, sucking the milk vitiated by *tridoṣa* or of wet nurse, who is multiparous, is of *vāta* or *pitta prakṛti*, has excessive or salty milk, becomes lame, idiot and dumb.

शिशु के व्याधि-युक्त होने पर धात्री की शोधन-चिकित्सा (*Purifying measures for wet-nurse in the diseases of breast-fed infant*)

शिशोव्याधौ समुत्पन्ने धात्रीणामेव शोधनम् । अतं बालसुखायेति को लोके नावबुद्धयेति ॥
यस्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पूर्वसञ्ज्ञयः । अनुद्भूते कथं तस्मिन् ॥
..... (व्याधिस्तस्य) प्रशाम्यति । अनागताविधातस्तु न वर्धयति वाऽऽशयम् ॥
उभयोस्तु यदा सम्यक् शोधनं कुरुते भिषक् । तदाऽऽरोप्यं भवत्यायुः शिशोर्लैखायवाऽऽमनि ॥
दोषाणामाशयो धात्री भूधराः सतितां भिव) ॥ ॥
..... तेभूतो दोषो बालं प्रबाधते ॥ तयोः संशोधनमूने न शान्तिरिति धारणा ॥

(का० सं० चि० ३/६-११)

शिशु को व्याधि उत्पन्न होने पर धात्री का ही शोधन करना चाहिए, इसीसे बालक को सुख प्राप्त हो जाता है; इस तथ्य को लोक में कौन नहीं जानता (अर्थात् सभी जानते हैं) । परन्तु (बालक के) शरीर में पहुँचे हुए दोषों का जो पूर्व सञ्ज्ञ होना है उसे बिना उद्भूत किए या निकाले, उसकी व्याधि किस प्रकार शान्त हो सकती है ? (अर्थात् व्याधि का नाश नहीं होता) तथा उसके भविष्य का नाश होता है एवं उसके आशय (शरीर के विभिन्न आशयों) की वृद्धि नहीं होती । जब वैद्य दोनों (धात्री एवं शिशु दोनों) का सम्यक् प्रकार से शोधन करता है तो बालक को तत्काल ही आरोप-लाभ हो जाता है, यह तथ्य परस्पर के लेख के समान सत्य है ।

जिस प्रकार पर्वत नदियों के आशय (उद्गमस्थान) हैं, उसी प्रकार धात्री दोषों का आशय होती है । (धात्री के शरीर में प्रकृतिपित्त हुए) दोष (बालक के शरीर में पहुँच कर) बालक को कष्ट पहुँचाते हैं अतः उन दोनों (धात्री एवं बालक) के संशोधन के बिना निश्चित रूप से (बालक के) रोगों की शान्ति नहीं होती ।

If the child (breast fed infant) becomes ill, *sōdhaṇa* (use of purifying measures) therapy given to the wet-nurse eradicates diseases of the child. However, if the *doṣas*, already accumulated in the child, are not removed, he is not cured, his future is destroyed and his body does not grow properly. When the physician uses purifying measures in both of them i.e. wet-nurse and child, then the child becomes immediately free from diseases.

As the rivers originate from hills, similarly wet-nurse is source of origin of all the *doṣas*. The *doṣas* vitiated in the body of wet-nurse, reach of child (through milk) and trouble him, thus till the *sōdhana* is not used in both (wet-nurse and child) of them, the diseases of child are not cured.

स्तन्यदुष्टि (Abnormalities of breast milk)

स्तन्यदुष्टि के सामान्य कारण एवं सम्प्रति (Etiopathogenesis of vitiation of milk)

अजीर्णामातृविषमविरुद्धार्थभोजनात् । तवणापस्तकटुक्षारप्रक्रियानां च सेवनात् ॥ २३२॥
मनःशरीरसंतापादस्वजागृति चिन्तात् । प्रसवेगप्रतीघातादप्रसोदोरणेन च ॥ २३३॥
परमात्रं गुडकृतं कुशरां दीधमदकम् । अभिष्यन्दीनि मांसानि प्राप्यानूदीकानि च ॥ २३४॥
भुक्त्वा भुक्त्वा दिवास्वप्नमद्यस्यतिनिधेयणात् । अनायासादभीघातात् क्रोधाच्चानूदीकशर्तैः ॥ २३५॥
दोषः क्षीरवहः प्राप्य सिराः स्तन्यं प्रदूष्य च । कुर्युष्टिविषं भूयो दोषतस्त्रिबोध मे ॥ २३६॥
(च० सं० चि० ३०/२३२ से २३६)

धन्यास्तु गुरुभिर्भोज्यैर्विषमैर्दोषैस्तथा । दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदूष्यति ॥ ३२॥

मिथ्याहारविहारिण्या दुष्टा वातादयः सिन्ध्याः । दूषयन्ति पयस्तेन ॥ ३३॥

(सु० सं० शा० १०/३२ व ३३)

क्षीरं हि यथोक्तैर्दोषकोपनैराहारविहारैर्वाभ्या व्यापन्नं विविधामयोदयाय बालस्य प्रकल्पते ॥

(अ० सं० उ० २/३)

अजीर्ण, असाम्य, विषम, विरुद्ध तथा अत्यधिक भोजन, तवण, अमल, कटु, क्षार तथा प्रक्रिय (द्रव्यों के) सेवन; मन एवं शरीर के संताप, रात में न सोने, चिन्ता (अधिक) करने, प्राप्त वेगों के धारण तथा अग्राम वेगों के उदीर्ण करने; परमात्र (खीर), गुड़ से बने भक्ष्य पदार्थों, कृशरा, दीध, मन्दक (पाठभेद मत्स्यक या मछली) एवं अभिष्यन्दी द्रव्यों के प्रयोग, ग्राप्य, अनूप तथा औदक प्राणियों के मांस आदि के सेवन, बार बार भोजन कर दिन में सोने, मद्य के अतिसेवन; परिश्रम न करने, अभिघात, क्रोध, अन्य व्याधियों तथा कशेरु (शरीर के अपतण द्वारा या अन्य कारणों) से अतिकृश हो जाने से) आदि से दूषित दोष क्षीरवह सिराओं में जाकर स्तन्य को दूषित कर अष्टविध क्षीरदोष उत्पन्न करते हैं । उन्हें उनके (दोषों के) अनुसार कहा जा रहा है ।

महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा है कि धात्री के द्वारा गुरु, विषम तथा दोषोत्पादक आहार का सेवन करने से शरीर के दोष प्रकुपित हो जाते हैं, जिसके कारण स्तन्य भी दूषित हो जाता है । मिथ्या आहार-विहार करने वाली स्त्री के वातादि दोष दूषित होकर दुग्ध को भी दूषित कर देते हैं ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने कहा है कि पूर्ववर्णित (सूत्रस्थान वर्णित) दोषों को प्रकुपित करने वाले आहार-विहार का सेवन करने से धात्री का दुग्ध दूषित हो जाता है तथा बच्चों को अनेकों प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करता है ।

माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर आदि पुस्तकों में भी महर्षि सुश्रुत के विचारों का अनुसरण किया गया है^१ ।

१. (अ) गुरुभिर्विषमैश्चैतुर्दृष्टैर्दोषैः प्रदूषितम् । क्षीरं मातुः कुमारस्य नाग योग्य कल्पते ॥ (मा० नि० ६७/५)

(आ) धान्यागुरुभिहारैर्बहिर्दोषैस्तथा । देहे दोषाः प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदूष्यति ॥

मिथ्याऽऽहारविहारिण्या दुष्टा वातादयः सिन्ध्याः । दूषयन्ति पयस्तेन शरीरं व्यापयः शिशोः ॥

(मा० प्र० पूर्व० ४/१६, १७)

(इ) गुरुभिः...प्रदूषितम् । क्षीरं धान्याः कुमारस्य..... (मा० नि० स० २०) क्षीरदोषचि०)

(ई) धान्यास्तु गुरुभिर्भोज्यैर्विषमैर्दोषैस्तथा । दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदूष्यति ॥

मिथ्याहारविहारिण्या दुष्टाः वातादयश्च । दूषयन्ति पयस्तेन जायते व्यापयः शिशोः ॥

(मा० प्र० चि० ७१/१६, ११७ एवं यो० २० बालो०)

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

महर्षि काश्यप ने चालक, पित्तज एवं कफज स्तन्यदुष्टि के विशिष्ट निदानों का वर्णन किया है जिनका उल्लेख विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है ।

Due to indigestion, consumption of non-congenial, unusual or unfavourable and incompatible food and over-eating; use of (excessive) salty, sour, hot, *kṣāra* (alkaline) and humid or putrified articles; diseases of body and mind, awakening in the night, over worry, suppression of natural urges and attempt to excrete feces etc. in the absence of their urge; use of *paramāna* (a dish made with rice, milk and sugar boiled together), dishes made of jagery, oleo, curd, slowly formed curd or fish. *abhiyanā* (moisture producing) articles, meat of wild or aquatic animals or animals frequenting marshy places, sleeping during day after eating repeatedly, over use of wine, absence of exercise, trauma, anger, other diseases and emaciation (either due to over use of purging etc. purifying measures or due to other causes), the *doṣas* get vitiated. These vitiated *doṣas* moving through *kṣīravahā* *sirās* (milk channels) vitiate the milk and produce eight types of milk disorders.

Suśruta, Vāgbhata I, Mādhava Nidāna, Bhāvaprakāśa and Yogaratnakara etc. have also given similar causes but in summarized way.

Kāśyapa has described specific etiology of vitiation of milk by *vāta*, *pitta* and *kapha*, which is recapitulated under specific headings.

दूषित स्तन्य-पान जन्य सामान्य व्याधियाँ (Diseases caused by use of vitiated milk)

सभी आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि वातादि दोषों से दूषित स्तन्य का पान करने से, बालकों को उन दोषों से उत्पन्न अनेकों शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं^१ ।

महर्षि काश्यप ने भी उपर्युक्त मत का अनुमोदन^२ किया है ।

Due to consumption of milk vitiated by *vāta* etc. *doṣas*, the child suffers from various physical disorders of the same *doṣa*, by which the milk is vitiated.

स्तन्य-दोषों के भेद (Classification of disorders of milk)

सभी आचार्यों ने वातादि तीनों दोषों से पृथक्-पृथक् तीन तथा सन्निपात जन्य इस प्रकार चार प्रकार के स्तन्य-दोषों का वर्णन किया है । महर्षि सुश्रुत ने अभिघातज एवं अष्टाङ्गहृदयकार तथा माधव आदि ने द्वन्द्वज स्तन्यदुष्टि की भी कल्पना

१. (अ) क्षीरं वातादिभिर्दुष्टं संभवति तत्पानकाः ॥ (च० सं० चि० ३०/२५१)

(आ) दूषयन्ति पयस्तेन शरीरा व्यापयः शिशोः ॥ (सु० सं० शा० १०/३३ तथा मा० प्र० पूर्व० ४/१७ शरीर-पाठ)

(इ) स्तन्यदोषाद् गदास्तस्य यथोक्तं तत् पिबेद्यतः ॥ (अ० सं० उ० १/३८)

...विविधामयोदयाय बालस्य प्रकल्पते ॥ तदुपयुज्यमानं यथास्वलिङ्गान् व्याधीनभिनिर्वर्तयति ॥

(अ० सं० उ० २/३, ७)

(ई)दुष्टाभ्यां योग्यसम्भवः ॥ १॥

यथास्वलिङ्गान्स्लङ्गशीनं जनयत्युपयोजितम् ॥ ५॥ (अ० उ० उ० २/१५)

(उ) कुमारस्य नाग योग्य कल्पते ॥ (मा० नि० ६७/५ तथा यो० २० क्षीरदोष चि०)

२. संभवन्ति महारोगा अशुद्धक्षीरसेवनात् ॥ (का० सं० सू० ११/२७)

की है। इस सामान्य सन्त्यदुष्टि के वर्णन के उपरान्त महर्षि चरक ने वातादि तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले अष्ट क्षीर-दोषों का वर्णन किया है। सम्भवतः इन अष्ट क्षीरदोषों को कल्पना वातादि जन्य विशिष्ट लक्षण-प्राधान्य यथा फेनसंघात आदि के आधार पर ही की गई है, अर्थात् सन्त्य में जिस विशिष्ट लक्षण का अन्य लक्षणों से अपेक्षकृत प्राधान्य हो उसे उसी नाम से लिखा गया, इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से और हो जाती है कि चिकित्सा स्थान में वे लिखते हैं कि वातादि दुष्ट सन्त्य के लक्षण तथा चिकित्सा एवं अष्ट क्षीरदोष का वर्णन मैं पूर्व पृष्ठों में कर चुका हूँ, यहाँ मध्यम एवं मन्द बुद्धि शिष्य के ज्ञानार्थ विस्तृत विवेचना दे रहा हूँ। जब कि शरीरस्थान वर्णित दुग्ध-दोषों में वातादि के वर्णन के अन्तर्गत वैरस्य, फेनसंघात आदि लक्षणों का उल्लेख तो अवश्य है परन्तु अष्ट क्षीरदोष का नामोल्लेख नहीं है। सूत्रस्थान में अष्टक्षीर-दोषों की गणना की गई है। महर्षि हारीत ने पञ्च क्षीरदोषों की कल्पना की है, तथा महर्षि काश्यप ने ग्रह-दूषित सन्त्य की। महर्षि काश्यप ने त्रिदोष दूषित, स्वादु एवं कषाय रस सन्त्य लक्षणों का उल्लेख किया है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने विभिन्न सन्त्य-दोषों की चिकित्सा का वर्णन करते हुए तिकागुरुस, केनिल, विच्छिन्न, प्लवमान, तनु, सान्द्र एवं ग्रथित आदि विकारों की चिकित्सा तथा ताम्रावभास, अम्लानुरस, कटुकानुरस, भृशोष्ण, लवणानुरस तथा तनुमत् सन्त्य-पान से होने वाले विकारों एवं इनकी चिकित्सा का वर्णन दिया है। इस प्रकार इन्होंने चांदह लक्षणों का विशिष्ट वर्णन दिया है।

शाङ्गधर संहिता में वातादि दोष-जन्य के ही साथ क्षतज सन्त्य-दुष्टि का भी वर्णन है, परन्तु इन्होंने केवल नामोल्लेख ही किया है^१।

विषय के सम्बन्ध ज्ञानार्थ सभी आचार्यों द्वारा वर्णित भेदों का उल्लेख तालिका १२ में किया जा रहा है।

तालिका १२

सन्त्यदुष्टि	वर्णित-ग्रन्थ	
१. वातज	च०सं०; सु०सं०; अ०सं०; अ०हं०; का०सं०; मा०नि०; शा०सं०; भा०प्र०; यो०र०	
२. पित्तज	उपर्युक्त सभी	
३. कफज	उपर्युक्त सभी	
४. द्रव्ज	अ०हं०; मा०नि०; भा०प्र०; यो०र०; चक्रपाणि टीका	
५. सान्निपातज	सु०सं०; अं०सं०; अ०हं०; का०सं०; मा०नि०; भा०प्र०; यो०र०; चक्रपाणि टीका	
६. क्षतज	शा०सं० (केवल नामोल्लेख)	
७. अभिघातज	सु०सं० एवं मधु०व्या०	
८. अष्ट क्षीरदोष	च०सं०	
९. तिकाषायानुरस, केनिल, विच्छिन्न,	अ०सं० (केवल चिकित्सा)	

क्रमशः.....

१. धात्रीसन्त्यसंयुक्ता विस्तारतः पुरा। सन्त्यसंजनं चैव सन्त्यस्य च विशेषम् ॥
वातादिदुष्टे सिद्धं च क्षीरस्य च चिकित्सितम्। तत्सर्वमुक्तं ये त्वष्ट्री क्षीरदोषाः प्रकीर्तिताः ॥
वातादिचैव तानुविद्याच्छास्त्रचक्षुर्भिरुक्तमः। त्रिविधास्तु यतः शिष्यास्ततो वक्ष्यामि विस्तारम् ॥

(च० सं० वि० ३०/२२९ से २३१)

२. पञ्चैव सन्त्यरोगाः स्युर्वातिपलाकफादपि। सन्निपाताक्षताच्चैव तथा सान्योद्भवा गताः ॥ (शा० सं० पूर्व० ७/१८२)

..... क्रमशः

सन्त्यदुष्टि	वर्णित-ग्रन्थ
प्लवमान, तनु, सान्द्र एवं ग्रथित	
१०. ताम्रावभास, अम्ल एवं कटुकानुरस, भृशोष्ण, लवणानुरस, तनुमत्, गुरु	अ०सं० (विकार एवं चिकित्सा)
११. षष्ठी, स्कन्द, पूतना एवं शकुनि ग्रह से दूषित	का०सं० केवल लक्षणों का वर्णन, धात्री के अपेक्ष्य सेवन-जन्य षष्ठी से आक्रान्त सन्त्य (पृष्ठ ६७०)
१२. स्वादु एवं कषाय रस का सन्त्य	का०सं० (विकार वर्णन)
१३. घन, उष्ण, अम्ल, एवं क्षार क्षीर (पञ्चक्षीर दोष)	हा०सं० (विकार वर्णन)

The authors have classified various disorders of milk, according to dominance of *dosa* or physical characters of milk. Some of these disorders have been described in detail, while for others only symptoms in the child and their treatment is given. To have a comprehensive idea regarding various abnormalities described by different authors the same are being given in tabular form.

No	Disorders of milk	Subject described	Authors
1-3	<i>Vātaja, Pittaja and Kapaja</i>	Etiology, physical characters of milk, Symptoms in the child and treatment.	C.S.; S.S.; A.S.; A.H.; Kā.S.; M.N. (excluding treatment); Śā.S. (only name); B.P. and Y.R.
4.	<i>Dwandwaja</i>	do	A.H.; M.N.; B.P.; Y.R. and C.P.
5.	<i>Sānnpātaaja</i>	do	S.S.; A.S.; A.H.; Kā.S.; M.N.; B.P.; Y.R. and C.P.
6.	<i>Kṣataja</i>	Name only	Śā.S.
7.	<i>Abhigṛātaaja</i>	Etiology and clinical features.	S.S.; Madhu.
8.	<i>Aṣṭa kṣīradōṣa</i>	Etiopathogenesis, physical characters, symptoms of the child and treatment.	C.S.
9.	<i>Tikakāṣṭyanurasa, phenila, vicchinna,</i>	Only treatment.	A.S.

Cont.

..... Cont.

No	Disorders of milk	Subject described	Authors
	<i>plavamāna, tanu, sandra and gṛathita</i>		
10.	<i>Tamāvabhāsa, anla and kajikānurasa, bhr̥ṣṇa, lavamānura, asa, tanumat and gura.</i>	Symptoms and treatment.	A.S.
11.	Milk. afflicted with <i>śaṣṭhi, skanda, pūlana and śekuni gṛahas.</i>	Symptoms of the child.	Kā.S.
12.	<i>Swādu and kaṣṭya taste.</i>	Only symptoms.	Kā.S.
13.	<i>Ghana, usṇa, anla, alpa and kṣāra kṣūra</i>	Only symptoms.	Hā.S.
	etc. five disorders.		

वातादि दोषों से दूषित स्तन्य का वर्ण एवं रस तथा शिशु में उत्पन्न होने वाले लक्षण (Physical characters of milk vitiated by different dosas and symptoms produced in the child)

(अ) वातज स्तन्य-दुष्टि (Milk vitiated by vāta)

श्यावारुणवर्ण कषायानुरसं विशदमनालक्ष्म्यन् रक्षं इवं फेनितं लघ्वतुमिकरं कर्शनं वातविकाराणां कर्तुं-वातोपसृष्टं क्षीरमभिज्ञेयम् ॥ (च० सं० शा० ८/५५)

तत् कषायं भवेद् वातात् क्षिप्तञ्जं प्लवतेऽम्भसि ॥ (सु० सं० नि० १०/२३)

तत्र श्यावारुणवर्णं तित्तकषायानुरसं विशदं रक्षमलक्ष्म्यन् फेनितमनुतिकामाध्याममूत्रवर्चोविबन्धकृतं कर्शनमप्यु विसर्पति विच्छिन्नं च प्लवते वातदुष्टम् ॥ (अ० सं० उ० २/४)

..... वाताद् दुष्टं तु प्लवतेऽम्भसि ॥ २॥

कषायं फेनितं रक्षं वर्चोमूत्रविबन्धकृतं ॥ ३॥ (अ० ह० उ० २/३, २)

तत्र या बालस्य माता वा धात्री वा रूक्षसमुदाचाराहारोदावर्तनोपवसनशीला तथाऽतिचङ्क्रमणव्यायामकरोषा-नत्यशुभसेवते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्षणम्-उदके प्रक्षिप्तं प्लवते विच्छिद्यते छात्रायते श्यावावभासं, रसेन तित्तकषायं विरसं वेति । (का० सं० खि० १५/७)

श्याव या अरण वर्ण, कषाय अनुरस वाले (पीने के बाद मुख में कषाय रस की अनुभूति हो), विशद, अनालक्ष्म-गन्ध (जिसकी गन्ध का परिज्ञान न हो अर्थात् गन्ध-रहित), रूक्ष, इव, फेनित, लघु, अतुमिकर, कर्शन (पीने वाले शिशु के शरीर को कृश बनाने वाला) तथा वात-विकारों को उत्पन्न करने वाले स्तन्य को वात से दूषित जानना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत ने संक्षेप में लिखा है कि वात से दूषित स्तन्य कषाय रस वाला होता है, तथा जल में डालने पर तैरता

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

रहता है । टीका डल्लण ने तनु आदि लक्षणों के ग्रहण का भी निर्देश दिया है^१ ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि वात से दूषित स्तन्य श्याव या अरण वर्ण, तित्त एवं कषाय अनुरस, विशद, रूक्ष, अलक्ष्म-गन्ध, फेनित, अनुतिकारक, आध्मा तथा मूत्र एवं मल विबन्ध-कारक तथा कर्शन करने वाला होता है । जल में डालने पर फैलता है एवं विच्छिन्न होकर अर्थात् अलग अलग या टुकड़े टुकड़े होकर तैरता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि वात से दूषित स्तन्य जल में तैरने वाला, कषाय रस, फेनित, रूक्ष तथा मल-मूत्र का विबन्ध-कारक होता है ।

महर्षि काश्यप का कथन है कि जब बालक की माँ या धात्री अत्यधिक रूक्ष आहार एवं आचम, उदावर्तन (वेगवरोध) एवं उपवास करती है तथा अत्यधिक धूमन एवं व्यायाम आदि क्लेशों का सेवन करती है, तब उसकी वायु प्रकुपित होकर स्तन्य को दूषित कर देती है । उसके (उस दूषित स्तन्य के) ये लक्षण हैं-वह जल में डालने पर तैरता है, विच्छिन्न हो जाता है अर्थात् फट सा जाता है, छात्रकार (अकृति का) हो जाता है, वर्ण में श्यावावभास तथा रस में तित्त, कषाय अधवा विरस होता है ।

इस स्तन्य के पीने से वातज चर्मदल होने का भी उल्लेख है^२ ।

माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगरत्नाकर आदि पुस्तकों में लिखा है कि वात से दूषित स्तन्य कषाय रस तथा जल में तैरने वाला होता है^३ । मधुकोष-व्याख्याकार ने डल्लण की ही भाँति तनु आदि का भी उल्लेख किया है^४ । पुनश्च बालरोगों का वर्णन करते हुए इन्होंने आचार्यों ने लिखा है कि वात से दूषित स्तन्य पन से बालक अनेकों वातव्याधियों से पीड़ित होता है । वह क्षाम-स्वर (धके हुए स्वर वाला या धीमे स्वर वाला), कृशाङ्ग तथा मूत्र, मल एवं वायु के विबन्ध या अवरोध से पीड़ित होता है^५ ।

The milk vitiated by vāyu is blackish brown or pinkish in colour, has kaṣṭya anurasa (feeling of kaṣṭya or astringent taste after sucking the milk or after taste), is viśāda (pellucid or non slimy), has indiscernible smell, is rukṣa (dry or absence of unctuousness), draṇa (liquid), frothy and laghu; does not give satisfaction to the child, produces emaciation and various disorders of vāta.

Suśruta says that it has kaṣṭya rasa (astringent taste) and if put in the water, it floats. Vāgbhaṭa I corroborating Caraka has added that it has tika anurasa also and produces flatulence, oliguria and constipation, the milk floats in the water in scattered manner. Vāgbhaṭa II has also given almost similar description.

Kāśyapa says that when mother or wet-nurse of the child constantly uses dry mode of life and dietetics, does retention (suppression of natural urges), observes fasting and in-

१. क्षिप्तोति चकोण अमुकमपि तनुच्चादिकम् समुच्चायेत् ॥ (सु० सं० नि० १०/२३ की डल्ल० टीका)

२. का० सं० खि० १५/७

३. कषायं सलिलज्वालि स्तन्यं मारुतदूषितम् ॥ (मा० नि० ६७/६, भा० प्र० पूर्व० ४/१८ एवं यो० २० क्षीरोषचि०)

४. तेन तनुच्चाद्यपि बोद्धव्यम् ॥ (मा० नि० ६७/६ की मधु० व्या०)

५. वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन् चालादातुरः । क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद्भ्रूविवमूत्रमास्तः ॥

(मा० नि० ६८/१, भा० प्र० चि० ७०/११८ एवं यो० २० बालरोगे नि०)

induces in too much or over walking, exercise etc. troubles, then her *vāyu* getting agitated viates breast-milk. Its features are — it floats when put in water, gets scattered, spreads like umbrella, it appears blackish in colour, it is bitter and astringent in taste or tasteless.

Carmadala (allergic dermatitis) due to *vāta* is said to develop due to consumption of this milk.

MādhavaNidāna, Bhāvaprakāśa and Yogaratnākara etc. giving description like *Suśruta*, have added that the child has very weak cry, is scrappy and suffers from suppression or retention of urine and feces.

(आ) पित्तज स्तन्य-दुष्टि (Milk vitiated by pitta)

कृष्णनीलपीताम्नावभासं तित्तावभासं कृष्णपरीधिराग्निं भूशोष्णं पित्तविकाराणां कर्तुं च पित्तोपसृष्टं क्षीरमभिज्ञेयम् ॥ (च० सं० शा० ८/५५)

पित्तादस्त सकटुकं राग्योऽम्भसि च पीतिकाः । (सु० सं० नि० १०/२४)

कृष्णनीलताम्नावभासं तित्तावभासं^१ तित्तावभासकटुकानुरसं कुणपरीधिराग्निं भूशोष्णमप्यु पीतान्जिमद्विदाहकं च पित्तदुष्टम् ॥ (अ० सं० उ० २/५)

पित्ताद् दुष्टावभासकटुकं पीतान्जमप्यु दाहकम् ॥ (अ० ह० उ० २/३)

यदा तु धात्री क्रोधसंतपोष्णान्स्त्वणकटुकविदाधायशनिवशात्ताजुपसेवते तस्याः पित्तं प्रकुपितं वायुना विश्विद्यमाणं स्तन्यवहाभिः सिराभीरनुसृत्य स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्षणानि—उदके प्रक्षिप्तं हरितकासितवभासं भवत्यथ रसेन कटुवस्त्वणवित्तं स्पर्शोष्णमिति । (का० सं० वि० १५/८)

कृष्ण, नीले, पीले या ताम्र वर्ण, तिक, अम्ल एवं कटु अनुरस तथा कुणप एवं खरि गन्धि वाला, अत्यधिक उष्ण तथा पित्त-विकार-कारक स्तन्य पित्त से दूषित समझना चाहिए ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि पित्त से दूषित स्तन्य अम्ल एवं कटु रस का होता है तथा इसे जल में डालने पर पीले वर्ण की रेखायें बनती हैं । टीकाकार डल्हण ने लिखा है कि स्तन्य सकटुक अर्थात् कुछ तिक रस वाला होता है क्योंकि कटु शब्द तिक को भी बोधित करता है तथा जल में पीले के ही साथ नीली एवं लाल रेखायें भी बनती हैं^३ ।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि पित्त दुष्ट स्तन्य कृष्ण, नीले या ताम्र वर्ण का, तिक, अम्ल एवं कटु अनुरस, कुणप एवं खरि गन्धि वाला, अत्यधिक उष्ण, (जल में डालने पर) पीली रेखायें बनाने वाला तथा विदाहकारी होता है ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि पित्त से दूषित स्तन्य अम्ल एवं कटु रस, जल में पीली रेखायें बनाने वाला तथा दाहकारक होता है ।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि जब धात्री क्रोध, सन्ताप, उष्ण, अम्ल, लवण, कटु रस युक्त तथा विदाध आहार एवं अस्थान आदि के विषय हो जाती है अर्थात् इनके वशीभूत हो जाती है, तब उसका प्रकुपित पित्त वायु के द्वारा प्रक्षेपित

१. तित्तावभास शब्द का कोई औचित्य इस स्थल पर प्रतीत नहीं होता । चरक के वर्णन में यह शब्द नहीं है । यहाँ पर सम्भवतः मुद्रण-त्रुटि के कारण उल्लिखित है । यह शब्द आठवले द्वारा पुणे से प्रकाशित गन्ध में नहीं है ।

२. सकटुक ईशतिकं, तिकेऽपि कटुशब्दस्य प्रवृत्तेः । अभसि चेति चकारानीललोहितश्च राग्यो दूष्टव्याः ॥

(सु० सं० नि० १०/२४ की डल्ह० टीका)

हो स्तन्यवहा सिराओं का अनुसरण करते हुए स्तन्य को दूषित करता है । इसके (इस स्तन्य के) ये लक्षण हैं :-जल में डालने पर हरे, लाल या काले से वर्ण का, रस में कटु, अम्ल, लवण एवं तिक तथा स्पर्श में उष्ण होता है ।

इस स्तन्य के पान से बालकों को पौष्टिक चर्मदल होने का भी उल्लेख है^४ ।

माधवनिदान तथा योगरत्नाकर आदि ग्रन्थों में इसके कटु, अम्ल एवं लवण रस तथा पीत रानी युक्त होने का उल्लेख है^५ । भयस्कण ने लवण रस नहीं माना^६ । मधुकोष व्याख्या में कटु शब्द से तिक रस के भी ग्रहण का तथा नील, लोहित आदि रेखाओं एवं जल में डूबने का उल्लेख है^७ । पुनश्च बालरोगों का वर्णन करते समय इन आचार्यों ने लिखा है कि पित्त से दूषित स्तन्य के पान से बालक र्विन्न (अत्यधिक स्वेद से आक्रान्त), मलभेद, कामला तथा अन्य पौष्टिक रोगों से पीड़ित, तृष्णालु होता है तथा उसके सभी अङ्ग उष्ण होते हैं^८ ।

The milk vitiated with *pitta* is black, blue, yellow or coppery in colour, possesses *tika* (bitter), *amla* (sour) and *kaiu* (pungent)*anurasa* (after taste), smells like blood or dead body (stinking), is very hot and produces disorders of *pitta*.

Suśruta says that it has *amla* and *kaiurasa* (taste); when put in the water, it produces yellow streaks. Dalhāṇa has added that it also has *tika rasa* and produces blue or red streaks also.

Vāgbhata I agreeing with Caraka has not described yellow colour but has added formation of yellow streaks in water and *viāḍha* (burning sensation) to the child. Vāgbhata II has also given almost similar description.

Kāśyapa says that when wet-nurse becomes helpless by anger, heat of sun and hot sour, salty and pungent diet, ill-digested food; eats again before digestion of previously taken food; then her aggravaled *pitta*, being thrown by *vāyu*, following the veins (channels) carrying breast-milk viates the breast-milk. Its (breast-milk's) features are - when splashed in water it becomes greenish, reddish or slight blackish in colour. In taste it is pungent, sour, salty and bitter and in touch it is hot.

By consuming this milk, the child is said to suffer from *carmadala* (allergic dermatitis) due to *pitta*.

MādhavaNidāna, Bhāvaprakāśa and Yogaratnākara agreeing with above description have added that the child consuming this milk, suffers from excessive perspiration, diarrhoea, *kāmala* (jaundice) and other disorders of *pitta*. He feels excessive thirst and body parts become hot. Madhukoṣa commentary has mentioned that this milk settles down in the water.

१. का० सं० वि० १५/८

२. कटुवस्त्वणवण पीतानीमत् पित्तसंज्ञितम् ॥ (मा० नि० ६७/६, यो० २० क्षीरदोष चि०)

३. पित्तादस्तं च कटुकं राग्योऽम्भसि तु पीतिकाः ॥ (पा० प्र० पूर्व ४/१८)

४. कटुवस्त्वणवणमिति कटु तिकं, तिकेऽपि कटुशब्दप्रवृत्तेरिति वदन्ति । पीतान्जमदिति पीतरेखायुक्तं, तत्रापि नीललोहितश्च राग्यो ज्ञेयः । निमज्जति पित्तदुष्टसंज्ञितम् ॥ (मा० नि० ६७/६ की मधु० व्या०)

५. तिको भिन्नमलो बालः कामलाभितरोभवन् । तृष्णालुलण्घनसर्वाङ्गैः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥

(मा० नि० ६८/२; पा० प्र० चि० ७१/११९ एवं यो० २० बालरोगे)

(इ) श्लेष्मज सन्त्य-दुष्टि (*Milk vitiated by Slesma*)

अत्यधुक्लमतिमाधुर्योपपन्नं लवणानुरसं घृततैलवसामज्जागन्धि पिच्छलं तन्तुमृदकपानेऽवसीदच्छ्लेष्म-
विकाराणां कर्तुं श्लेष्मोपसृष्टं क्षीरमभिज्ञेयम् ॥ (च० सं० शा० ८/५५)

कफाद् घनं पिच्छलं च जले चाप्यवसीदति ॥ (सु० सं० नि० १०/२४)

अत्यधुक्लमधुं लवणानुरसं घृततैलवसामज्जागन्धि पिच्छलं बहलं तन्तुमृद् गुरु सलिलेऽवसीदति निद्राबहुलं च
श्लेष्मदुष्टम् ॥ (अ० सं० उ० २/६)

कफाद् सलवणं सान्द्रं जले मज्जति पिच्छलम् ॥ (अ० ह० उ० २/४)

अथ या धात्री गुर्वललवणमधुराभिध्वादिदिवस्वप्नालस्यहितानि चात्यधुमुपसेवते तस्याः प्रकुपितः श्लेष्मा
वायुना समुदीर्यमाणः सन्त्यमभिरूषयति । तस्य लक्षणं—जले निषीदित्यधस्ताद्ग्रेण सान्द्रं स्नेहबहलं स्पर्शेन शीतोपिच्छलं
रसेन मधुरमिति । (का० सं० वि० १५/९)

अत्यधिक श्वेत, अत्यधिक मधुर, लवणानुरस, घृत, तैल, वसा या मज्जा गुल्म गन्ध युक्त, पिच्छल, तन्तु युक्त, जल-
पात्र में डालने पर डूब जाने वाला तथा श्लेष्म-विकार-कारक सन्त्य को कफ से दूषित जानना चाहिए । टीकाकार चक्रपाणि
ने लवणरसता का कारण दोष-दूष्य समर्पण बताया है ।

महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि कफ-दूषित सन्त्य घन (गाढा), पिच्छल एवं जल में डूबने वाला होता है ।

अष्टाङ्गसंग्रह में वर्णन है कि अत्यधिक श्वेत, अत्यधिक मधुर, लवणानुरस, घृत, तैल, वसा या मज्जा गन्धि, पिच्छल,
बहल (घन-इन्दु), तन्तुमृद्, गुरु, जल में डूबने वाला, अत्यधिक निद्राकारक सन्त्य कफ से दूषित जानना चाहिए ।

अष्टाङ्गहृदयकार ने लिखा है कि कफ (से दूषित होने) से सन्त्य लवण रस वाला, सान्द्र, पिच्छल एवं जल में
डूबने वाला होता है ।

महर्षि काश्यप का कथन है कि जब धात्री गुरु, अम्ल, लवण, मधुर एवं अभिष्यन्ती (भोजन) तथा दिवास्वप्न एवं
आलस्य आदि अहितकारी (विहार) का अत्यधिक सेवन करती है, तब उसका प्रकुपित श्लेष्मा वायु के द्वारा उदीर्यमान
(श्रीत) होकर सन्त्य को दूषित कर देता है । उसके (दूषित सन्त्य के) ये लक्षण हैं :- जल में डालने पर नीचे डूब
जाता है । देखने में सान्द्र (गाढा), अत्यधिक स्निग्ध, स्पर्श में शीत एवं पिच्छल तथा रस में मधुर होता है ।

माधवनिदान तथा योगरत्नाकरकार ने महर्षि सुश्रुत का ही अनुगमन किया है^१ । आचार्य भावमिश्र ने केवल पिच्छलता
एवं जल में अवसीदन का ही वर्णन किया है^२ । मधुकाष व्याख्या में अति माधुर्य आदि लक्षणों का भी उल्लेख है तथा जल
में डूबने का कारण अति गुरुत्व होना बताया है^३ । पुनश्च इन्हीं आचार्यों ने बालरोगाधिकार में लिखा है कि कफ से दूषित
सन्त्य-पान करने से शिशु लालातु (अत्यधिक लाला खाव पीड़ित), श्लेष्मरोगों से पीड़ित, निद्रानिवत (हर समय सोया रहने
वाला) तथा जड़ (क्रिया विहीन) होता है, उसके मुख एवं नेत्र शोथ युक्त होते हैं तथा वह वमन से पीड़ित होता

१. लवणानुरसमिति श्लेष्मदुष्टे क्षीरे दोषदूष्यसंभूर्धनभावान्नेयं, येन श्लेष्मदुष्टे लवणरसता भवति ॥

(च० सं० शा० ८/५५ की चक्र० टीका)

२. कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सपिच्छलम् ॥ (मा० नि० ६७/७)

कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति च सुपिच्छलम् (यो० १० क्षीरतोषे चि०)

३. कफदुष्टं तु यतोये निमज्जति च पिच्छलम् ॥ (पा० प्र० पूर्व० ४/१९)

४. तोये निमज्जति गुरुत्वात् । अतिमाधुर्याध्वनि बोध्यम् । (मा० नि० ६७/७ की मधु० व्या०)

सन्त्य एवं धात्री प्रकरण

६८१

है^{१,२} । आचार्य भावमिश्र ने मुखशोथ न लिख, नेत्र के शोथ-युक्त तथा रक्त होने का वर्णन दिया है^३ । रक्तक्ष के स्थान
में वक्त्राक्ष (नेत्र एवं मुख में शोथ) वर्णन अधिक युक्तिसंगत है, क्योंकि रक्तक्षता पित्रदुष्टि में होना अधिक सम्भाव्य है
न कि कफदुष्टि में ।

कफ से उत्पन्न होने वाले उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त आचार्य वाग्भट ने श्लेष्म-दूषित सन्त्य से बालशोथ नामक^४
बच्चों की व्याधि तथा महर्षि काश्यप ने फक्क रोग^५ एवं चर्मदल^६ की उत्पत्ति का भी वर्णन किया है, (जिनका वर्णन नहीं
किया जा रहा है ।)

The milk vitiated with *kapha* is excessively white and sweet, has *lavana anurasa* (after
taste), smells like *ghrita*, oil, fat or marrow, is *picchila* (slippery), has *tanu* (thread like
structures), settles down at the bottom when put in the water and produces various disorders
of *kapha*.

Suśruta says that it is *ghana* (thick), *picchila* and settles down in the water.

Vāgbhata I has added that it is also *vahala* (viscous or thick), *guru* (heavy) and causes
over sleepiness to the child. Vāgbhata II has followed Suśruta.

Kāśyapa says that the wet-nurse who uses excessively heavy, sour, salty, sweet, mois-
ture producing articles, day-sleeping, indolence and noncongenials, her aggrivated *slesma*,
being thrown by *vāyū*, vitiates breast-milk. Its (breast-milk's) features are—that it settles
down in the water, is thick in appearance and over unctuous, is cold and slimy in touch and
sweet in taste.

Mādhavanīdāna, Bhāvaprakāśa and Yogaratnākara, giving almost similar description,
have added that the child suffers from excessive salivation, various disorders of *kapha*,
always feels sleepy, is numb or idiot, has swelling of face and eyes and suffers from
vomiting. Bhāvaprakāśa has mentioned edema and redness of eyes instead of edema of face
and eyes, which does not seem to be proper because redness is the characteristic of *pitta*
not of *kapha*.

While describing various pediatric disorders, Vāgbhata and Kāśyapa have mentioned
bālāśoṣa and *phaka* along with *carmadala* (allergic dermatitis) respectively due to con-
sumption of milk vitiated with *kapha*. Since specific pediatric disorders do not come under
perview of this book, hence, are not being described here.

(ई) द्वन्द्वज सन्त्य-दुष्टि (*Milk vitiated by two dosas together or dwandwaja*)

संयुष्ट लिङ्गम् संसर्गात् । (अ० ह० उ० २/४)

१. कफदुष्टं पिबन् क्षीरे लालातुः श्लेष्मरोगवान् । निद्रान्वितो जड़ः शूनवक्त्राक्षरुद्धनः शिशुः ॥ (मा० नि० ६८/३)

२. कफदुष्टं । निद्रादितो ॥ (मा० नि० सदृश) (यो० १० बालरोगे)

३. श्लेष्मदुष्टं पिबन्क्षीरे लालातुः श्लेष्मरोगवान् । निद्रादितो जड़ः शूनो रक्तक्षरुद्धनः शिशुः ॥ (पा० प्र० चि० ७१/१३०)

४. अ० सं० उ० २/४६; अ० ह० उ० २/४४, ४५, ४६

५. धात्री श्लैष्मिकदुग्धा वा फक्कदुग्धोत्पत्तिर्ज्ञेया ॥ (का० सं० चि० १७/४)

६. का० सं० वि० १५/९

दोषों का संसर्ग होने पर उन दोनों दोषों के मिश्र लक्षण होते हैं।
इन्हीं विचारों का प्रतिपादन चक्रपणि^१ टीका, माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगन्नाकर आदि में किया गया^{२,३,४} है।

When the milk is vitiated with two *dosas*, physical characters of both the *dosas* appear and child also manifests the symptoms of both the *dosas*.

(उ) सन्निपातज सत्यदुग्धि (*Milk vitiated by all the three dosas or sannipāyaja*)

सर्वदुष्टैः सर्वलिङ्गम् ॥ (सु० सं० नि० १०/२४)

..... विलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥ (अ० ह० उ० २/४)

..... पद्भुजदामूका विदोषक्षीरभोजिनः ॥ ५॥ (का० सं० चि० १७)

सभी दोषों से दूषित होने से उन सबके मिश्रित लक्षण होंगे। अष्टाङ्गहृदय, माधवनिदान, भावप्रकाश तथा योगन्नाकर आदि पुस्तकों में भी यही वर्णन है^{५,६,७}।

महर्षि काश्यप ने त्रिदोष-दूषित क्षीर पान से बालक को पङ्कुरा, जड़ता एवं मूकता के साथ उसके त्रिदोषज चर्म-दल से सीङ्ग^८ होने का वर्णन दिया है।

अष्टाङ्गसंग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय पुस्तकों में सत्य दोषों की चिकित्सा का वर्णन करते समय पुनः सान्निपातिक सत्य-दुग्धि का विस्तृत वर्णन किया है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि जब धात्री तीनों दोषों को प्रकृषित करने वाले आहार का सेवन करती है, तो तीनों दोष एक साथ वक्ष में आकर क्षीरवहा रसायनियों (नलिकाओं) का अनुसरण कर (उनके द्वारा स्तनों में पहुँचकर), सत्य को दूषित कर, मिश्रित लक्षण उत्पन्न करते हैं। जब अज्ञान, निरन्तर ध्यान न देने या (माता के) प्रमाद के कारण माता का दुग्ध बच्चा पीता है तो उसे विभिन्न लक्षणों वाला क्षीरालसक रोग हो जाता है^९। अष्टाङ्गहृदयकार ने भी लिखा है कि त्रिदोष दूषित सत्य पान से क्षीरालसक रोग हो जाता है^{१०}। क्षीरालसक बालरोग का विषय होने के कारण यहाँ वर्णित नहीं किया जा रहा।

योगन्नाकरकार ने भी त्रिदोषज सत्यपान-जनित लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि त्रिदोष दूषित सत्य-

१. एतदृप्रलक्षणेयोगाच्च द्वन्द्वसन्निपातदुग्धिर्युग्मेयः ॥ (च० सं० शा० ८/५५ की चक्रपणि टीका)
२. विलिङ्गं द्वन्द्वं विधात् ॥ (मा० नि० ६७/७; यो० २० क्षीरदो०)
३. द्वन्द्वं तु विलिङ्गं स्यात् ॥ (मा० प्र० पूर्व० ४/१९)
४. द्वन्द्वे द्वन्द्वं रूपं ॥ (मा० नि० ६८/४; मा० प्र० चि० ७९/२२१)
५. सर्वलिङ्गं त्रिदोषजम् ॥ (मा० नि० ६७/७; यो० २० क्षीरदोष)
६. विलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥ (मा० प्र० पूर्व० ४/१९)
७. सर्वत्रे सर्वलक्षणम् ॥ (मा० नि० ६८/४; मा० प्र० चि० ७९/२२१)
८. का० सं० चि० १५/१०
९. यदा पुण्याग्नी सन्निपातप्रकोपनायासेवेत तदास्यास्यो मला युगाद्दुःशोऽभिप्रायाः क्षीरवहा रसायनीः समनुसृत्य संकीर्णलिङ्गं सत्यमावहन्ति। तच्चेद्विज्ञानात् सततमलस्यलक्षणात् प्रमादद्वा मातुः कुमारः निवर्तित ततः स तेन प्रादुर्भवन्ति। तं क्षीरालसकमत्यं चावक्षते ॥ (अ० सं० उ० २/१७)
१०. सत्ये त्रिदोषमस्ति। क्षीरालसकमिन्याहुत्वं चातिदारुणम् ॥ (अ० ह० उ० २/२० सं २३)

पान से बालक को आम-युक्त, जल के समान (पतला), अनेकों प्रकार के चर्मा तथा वेदनाओं से युक्त तथा आधा नैषा एवं आधा पतला मल होता है^१।

Milk vitiated with all the *dosas* together exhibits physical characters as well as symptomatology of all the *dosas*.

Vāgbehata I has described this entity in detail in the treatment of milk-vitiation. He writes that when wet-nurse consumes the dietetics capable of vitiating all the *dosas*, then these aggravated *dosas* reach chest and following milk carrying channels vitiate the milk and produce mixed symptoms. When the mother due to ignorance, absence of constant care and negligence suckles the child, then the child suffers from disease *ksīrālāsaka* having various symptomatology. Vāgbehata II has also mentioned that consumption of this type of milk produces *ksīrālāsaka*. Since the disease relates to the children, hence is not being described here.

Child becomes lame, numb and dumb besides suffers from *carmadala* (allergic dermatitis) by consuming the milk vitiated with *tridosas* as per opinion of Kāśyapa.

Yogaratriakara has mentioned that due to consumption of milk vitiated by *tridosas*, the child passes stool which is mixed with *āma* (mucus), is liquid like water, has various colours, is associated with different types of pain and is semisolid or half solid and half liquid.

(ऊ) अभिघात जन्य सत्य दुग्धि (*Milk vitiation due to abhigghāta or trauma*)—

.....अभिघाताच्च दुष्यति ॥ (सु० सं० नि० १०/२४)

अभिघात से भी सत्य दूषित होता है। महर्षि सुश्रुत ने इस अभिघात जन्य सत्यदुग्धि के लक्षणों का उल्लेख नहीं किया है। अभिघात का स्मृष्टीकरण टीकाकार डक्कण ने पतन एवं प्रपीडन आदि शब्दों से किया है^३। मधुकोषव्याख्याकार ने लिखा है कि अभिघात जन्य सत्य दुग्धि में वातज सत्यदुग्धि-सदृश ही लक्षण होते हैं^३।

Milk gets vitiated due to trauma also, which is caused by fall or compression (of breasts). Madhukosa commentary has explained that this causes similar symptoms as seen in milk vitiated due to *vāta*.

(ए) ग्रह दूषित सत्य (*Milk vitiated by grahas*)

.....शकुनि कटुलक्तके। स्कन्धश्लेष्मिग्रहौ ज्ञेयौ व्याघ्रे सान्निपातिके।

पूतना स्वादुकटुके शेषाः संसृष्टदोषजाः ॥ (का० सं० सू० १९/२)

शकुनि ग्रह से आक्रान्त होने पर सत्य (का स्वाद) कटु एवं तिक्त होता है। यदि सान्निपातिक या सभी दोषों के मिश्र लक्षण दिखाई दें तो दुग्ध को स्कन्द एवं षष्ठी ग्रह से प्रभावित समझना चाहिए। पूतना से प्रभावित होने पर मधुर एवं कटु तथा अन्यो (ग्रहों से आक्रान्त होने) में संसृष्ट या दो दो दोषों के लक्षण होते हैं।

१. सत्ये त्रिदोषसंयुटे शकुन्याम जलोपमम्। नानावर्णरजं चाधीविबद्धमुपयेयते ॥ (यो० २० क्षीरदोषचि०)
२. अभिघातात् पतनपीडनादिकात् ॥ (सु० सं० नि० १०/२४ की डक्कण टीका)
३. अभिघातेनापि सत्यं दुष्टं संपवत्येव, किन्तु तस्य वातिकसत्त्वलक्षणौ च संश्लेषं कर्तव्यम् ॥

(मा० नि० ६७/७ की मधु० व्या०)

Milk vitiated by *śukrāṇi graha* is hot and bitter. If the milk has the characteristics of vitiation of *tridoṣa*, then it should be considered as afflicted by *skandha* and *śaśṇi graha*. Milk vitiated by *pīṭhā* is sweet and hot and affliction by other *grahas* shows the features of two *doṣas*.

(ऐ) गर्भिणी स्त्री के स्तन-पान एवं अन्न के साथ दुग्ध-पान से विकृति (Effect of sucking milk of pregnant woman and use of milk along with cereals)—

गर्भिणी स्त्री के स्तन का पान करने से बालकों को पारिणामिक^१ या फफू क व्याधि^२ हो जाती है। अन्न के साथ दुग्ध-पान करने से भी पारिणामिक व्याधि के लक्षणों यथा कास आदि की^३ उत्पत्ति हो जाती है। यह बाल रोग का विषय है अतः विवेचन नहीं दिया जा रहा।

Suckling of pregnant mother's milk produces *pāṇigrahika* or *pīṭhika*, a pediatric disorder. Use of milk with cereals also produces cough etc. symptoms just like *pāṇigrahika*. विभिन्न वर्ण या रस वाले स्तन्य के पान से होने वाले विकार (Effect of consumption of milk of different colours or tastes upon the child)

(अ) कषाय एवं मधुर स्तन्यपान जन्य लक्षण

बहुविपन्नता स्वादौ कषाये मूत्रविद्वग्धः ॥ (आ० सं० सू० ११/३)

मधुर रस के स्तन्य-पान से अत्यधिक मल, मूत्र प्रवृत्ति तथा कषाय रस के स्तन्य से मूत्र एवं मल का अवरोध या विवन्ध होता है।

(आ) पौनिक स्तन्यदुष्टि के विशिष्ट लक्षणों से सम्बन्धित व्याधियाँ

(१) ताम्रावभास स्तन्यपान जन्य लक्षण

ताम्रावभासं पयो हृदयमुद्वेष्टयति ॥ (आ० सं० उ० २/१४)

ताम्र वर्ण का स्तन्य (बालक के) हृदय (वक्षप्रदेश) का उद्वेष्टन (दबाव की प्रतीति या शूल) करता है।

(२) अस्मानुरस स्तन्यपान जन्य लक्षण

अस्मानुरसं अस्मापितकम् ॥ (आ० सं० उ० २/१४)

अस्मानुरस स्तन्य (बालक को) अस्मापित उत्पन्न करता है।

(३) कटुकानुरस स्तन्यपान जन्य लक्षण

कटुकानुरसं छर्द्यतीसारकासश्वासकम् ॥ (आ० सं० उ० २/१४)

कटुकानुरस स्तन्य (शिशु को) वमन, अतिसार, कास एवं श्वास कारक होता है।

१. आ० सं० उ० २/६४; मा० नि० ६८/१०, ११; मा० प्र० चि० ७१/१३३, १३४; यो० १० बालरोग चि०

२. का० सं० चि० १७/११

३. आ० सं० उ० २/६६

(४) भृशोष्ण स्तन्य-पान-जन्य लक्षण

भृशोष्णमानमादाहच्वरकरं विरेचनं च ॥ (आ० सं० उ० २/१४)

अत्यधिक उष्ण दुग्ध का पान अनाम (अनामक या गुरुकुट्ट), दाह, च्वर तथा विरेचन आदि उत्पन्न करता है।

(इ) कफज स्तन्य-दुष्टि के विभिन्न लक्षणों से बालकों में उत्पन्न विशिष्ट लक्षण

(१) लवणानुरस स्तन्यपान जन्य लक्षण

लवणानुरसं विसर्पकोठकण्डूकम् ॥ (आ० सं० उ० २/१६)

लवणानुरस स्तन्य विसर्प, कोठ तथा कण्डू आदि व्याधियों का उत्पादक होता है।

(२) तनुमत् स्तन्यपान जन्य लक्षण

तनुमद्दौर्बल्यश्वासकम् ॥ (आ० सं० उ० २/१६)

तनुमत् स्तन्य दौर्बल्य, श्वास एवं कास का उत्पादक होता है।

(३) गुरु स्तन्यपान जन्य लक्षण

गुरु सदनमकं प्रतिश्यायमिड्डाणकक्षीतालसकम् ॥ (आ० सं० उ० २/१६)

गुरु दुग्ध सदन (आलस्य), प्रतिश्याय, सिड्डाणक (अत्यधिक नासागल की प्रवृत्ति) तथा क्षीरालसक व्याधि को उत्पन्न करता है।

Due to consumption of milk having different abnormal qualities, the child exhibits various symptoms given here-under in tabular form—

S.N.	Character of milk	Effect on the child
a)	Specific taste	
i)	<i>Madhura rasa</i> (sweet)	Excessive excretion of urine and feces.
ii)	<i>Kāṣṭhā rasa</i> (astringent)	Retention of urine and feces or oliguria and constipation.
b)	Disorders produced by <i>pitta</i> —	
i)	<i>Tāmravabhāsa</i> (copper colour)	Feeling of compression, cramps or pain in cardiac region.
ii)	<i>Amlānūrasa</i> (secondary or after taste is sour)	<i>Amlapitta</i> (hyperacidity)
iii)	<i>Kaṭukānūrasa</i> (after taste is pungent).	Vomiting, diarrhoea, cough, dyspnoea.
iv)	<i>Bhīṣōṣṇa</i> (very hot)	<i>Anāma</i> (napkin rash), burning sensation, fever and diarrhoea.

Disorders produced by <i>kapha</i> —		
i)	<i>Lavanañārasa</i> (after taste is salish)	<i>Visarpa</i> (erysipelas), <i>kojha</i> (skin rashes and <i>kandū</i> (itching).
ii)	<i>Tanūmat</i> (having appearance like thread)	Weakness, dyspnoea and cough.
iii)	<i>Guru</i> (heavy)	Lethargy, coryza, <i>siṅghānaka</i> (excessive thick nasal mucus) and <i>kṣīrāśāka</i> .

Note : 'a' has been described by Kāśyapa and 'b' and 'c' by Vāgbhata I.

महर्षि चरक वर्णित अष्ट क्षीरदोष (Aṣṭa kṣīradōṣas or eight disorders of milk described by Caraka)

अष्टौ क्षीरदोषा इति वैवर्ण्यं वैरस्यं वैरस्यं वैरस्यं फेनसङ्गतो रौक्ष्यं गौरवमतिस्नेहश्च ॥

(च० सू० ११/३-१)

वैरस्यं फेनसङ्गतो रौक्ष्यं चेत्यनिलात्मके । पित्ताद्वैवर्ण्यदौर्गन्ध्यं स्नेहवैरस्यगौरवम् ॥

कफाद्भवति ॥ (च० सं० चि० ३०/२३७)

वैवर्ण्यं, वैगन्ध्यं वैरस्यं, वैरस्यं, फेनसङ्गतं, रौक्ष्यं, गौरव तथा अतिस्नेह ये आठ क्षीरदोष हैं ।

(इन आठ क्षीर दोषों में से) वैरस्य, फेनसङ्गत तथा रौक्ष्य वातज, वैवर्ण्य तथा दौर्गन्ध्य पित्तज तथा (अति) स्नेह, वैरस्य एवं गौरव कफज होते हैं ।

महर्षि कारश्य ने संख्योक्तेज (८ का) तो किया है, परन्तु विशिष्ट भेदों के नामों का वर्णन नहीं है ।

All these eight disorders are also caused by *vāta* etc. three *dōṣas*. However, this description is based on different physical characters of milk, which, inspite of having dominance of a particular *dōṣa*, produce entirely different symptoms in the child.

These eight disorders are *vairanyu* (discolouration) and *vairagandhya* or *duragandhya* (foul smelling) due to *pitta*; *vairasya* (tastelessness), *phenasāṅghāta* (frothy) and *raukṣya* (dryness) due to *vāta* and *aishreha* (excessive unctuous), *paicchiya* (slimy) and *gaurava* (heaviness) due to *kapha*.

Kāśyapa has mentioned only number as eight without any further description.

(१) वैरस्य सत्यदुष्टि के निदान तथा पानोत्पन्न व्याधियाँ (*Etiopathogenesis and clinical manifestations of vairasya or tastelessness or insipidity of milk*)

..... रुक्षदौर्गन्धः स्तैः प्रकोपणैः । कण्डः क्षीराण्यं प्राप्य रसं सत्यस्य दूषयेत् ॥

विरसं वातसंयुष्टं कृशीभवति तत् पिबन् । न चास्य स्वदते क्षीरं कृच्छ्रेण च विवर्धते ॥

(च० सं० चि० ३०/२३८, २३९)

रुक्ष आदि वात-प्रकोपक (आहार-विहार) के सेवन से कुपित हुआ वायु क्षीराण्य (स्तनों) को प्राप्त होकर सत्य के रस को दूषित कर देता है (अर्थात् उसके सामान्य मधुर रस को वायु विकृत कर देती है) ।

१.पयोदोगा.....अष्टौ.....। (का० सं० सू० २७/५५, ५६)

वात के संसर्ग से उत्पन्न विरस दुग्ध को पीने वाला बालक कृश हो जाता है, इस दुग्ध में कोई स्वाद नहीं आता तथा (वातक) बहुत ही कठिनाता से बढ़ता है ।

Dut to use of *rukṣa* etc. dietetics and mode of life capable of vitiating *vāta*, the aggravated *vāta* reaches breasts and vitiates the taste of milk or in other words normal sweet taste of milk is influenced and changed.

The child sucking this *virasa* (tasteless) milk, becomes emaciated, does not feel any taste in the milk and attains growth and development with great difficulty.

(२) फेनसङ्गत सत्यदुष्टि के निदान तथा पानोत्पन्न व्याधियाँ (*Etiopathogenesis and clinical manifestations of phenasāṅghāta or frothy milk*)

तथैव वायुः कुपितः सत्यमन्तर्विलोडयन् । करोति फेनसङ्गतं तनु कृच्छ्रान् प्रवर्तते ॥

तेन क्षामस्वरो बालो बद्धविषमूत्रमारुतः । वातिकं शीथरीयं वा पीनसं वाऽधिगच्छति ॥

(च० सं० चि० ३०/२४०, २४१)

उसी प्रकार से (रुक्षादि सेवन से) कुपित वायु (स्तनों में पहुँच कर) अन्तर्स्थित सत्य का विलोडन (मन्थन) कर देती है । जिससे फेनसङ्गत अर्थात् फेन की उत्पत्ति हो जाती है । यह सत्य बहुत ही कठिनाता से प्रवर्तित होता है ।

इसके पान करने से बालक क्षाम-स्वर (दुर्बल या थके हुए स्वर वाला) मल, मूत्र एवं वायु के विबन्ध या अवरोध से पीड़ित तथा वातिक शीथरीय एवं पीनस से आक्रान्त हो जाता है ।

The *vāyu*, vitiated due to use of *rukṣa* etc. articles, reaches breasts and churns the milk there. Due to this churning froth is produced. This milk is ejected with great difficulty.

The child sucking this milk has weak cry, retention or suppression of feces, urine and flatus, suffers from head-disorders of *vāta* and *pīnasa* (chronic rhinitis)

३) रुक्ष सत्यदुष्टि के निदान एवं पानोत्पन्न व्याधियाँ (*Etiopathogenesis and clinical manifestations of rukṣa or dry or non-unctuous milk*)

पूर्ववत् कुपितः सत्ये स्नेहं शोषयतेऽनीलः । रूक्षं तत् पिबतो रौक्ष्याद्बलह्रासः प्रजायते ॥

(च० सं० चि० ३०/२४२)

उपर्युक्त कारणों से कुपित वायु सत्य के स्नेहांश का शोषण कर देती है, जिससे (सत्य में) रूक्षता हो जाती है । इसे पान करने वाले बालक का बल-ह्रास हो जाता है ।

The *vāyu*, vitiated due to causes mentioned above, reaches breasts and desiccates the fatty substances of milk, so the milk becomes non-unctuous. The child consuming this milk suffers from loss of energy.

(४) वैवर्ण्य सत्यदुष्टि के निदान एवं पानोत्पन्न व्याधियाँ (*Etiopathogenesis and clinical manifestations of vairanyu or discolouration of milk*)

पित्तमुष्णादिभिः कृद्धं सत्याशयमभिप्लवन् । करोति सत्यवैवर्ण्यं नीलपीतासितकिम् ॥

विवर्णमात्रः सिन्नः स्यात्पुष्णालुर्भिन्नविदशिशुः । नित्यमुष्णशरीरश्च नाभिमन्दति तं स्तनम् ॥

(च० सं० चि० ३०/२४३, २४४)

उष्णादि (पदार्थों के सेवन या विहार) से कुपित पित्त, स्तन्यशय (स्तनों) पहुँच कर स्तन्य में नील, पीत या अस्ति (काला) आदि वर्णों को उत्पन्न कर देता है।

पान करने वाले शिशु का शरीर विवर्ण हो जाता है। अत्यधिक स्वेद आता है, वह ठण्ठालु होता है, उसे बिड़भेद हो जाता है, उसका शरीर हमेशा ही उष्ण रहता है तथा उसे स्तन्य-पान करने की इच्छा नहीं होती।

The *pitta*, aggravated due to use of hot etc. articles, reaches the breasts and produces blue, yellow and black etc. colours in the milk.

The child sucking this milk suffers from discolouration of body, excessive perspiration, thirst and diarrhoea. His body is always very hot and has no desire for sucking.

(५) दौर्गन्ध्य स्तन्यदुष्टि के निदान एवं पानोत्पन्न व्याधियाँ (Etiopathogenesis and clinical manifestations of daurgandhya or foul smelling milk)

पूर्ववत् कुपिते पित्ते दौर्गन्ध्यं क्षीरमुच्छति। पाण्ड्वामयस्तद्विवर्तः कामला च भवेच्छिरोः ॥

(च० सं० चि० ३०/२४५)

उपर्युक्त कारणों से ही कुपित हुआ पित्त दूध में दुर्गन्ध उत्पन्न कर देता है।

इसके पीने से शिशु को पाण्डुरोग तथा कामला हो जाता है।

The *pitta* vitiated due to above mentioned causes produces foul smell in the milk. The child sucking this milk suffers from *pāṇḍu* (anemia) and *kāmala* (jaundice).

(६) अतिस्निग्ध स्तन्यदुष्टि के निदान एवं पानोत्पन्न व्याधियाँ (Etiopathogenesis and clinical manifestations of atisngidha or excessive unctuous milk)

कुन्दो गुर्वादिभिः स्लेष्मा क्षीराशयगतः स्त्रियाः। स्नेहाचित्वात्तत्क्षीरमतिस्निग्धं करोति तु ॥

छर्दनः कुन्धनस्तेन लालालुज्जयते शिशुः। नित्योपादिभ्यः स्तोतोभिर्निद्राकल्मसमन्वितः ॥

श्रवासकासपरीतस्तु प्रसेकतमकाचितः। (च० सं० चि० ३०/२४६, २४७, २४८)

गुरु आदि (आहार के सेवन) से कुण्ड स्लेष्मा स्त्रियों के क्षीराशय (स्तनों) में जाकर, वह स्नेहाचित (स्वयं स्नेह-गुण युक्त) होने के कारण दूध को अतिस्निग्ध कर देता है।

(इस दूध के पान से) शिशु को वमन, कुन्धन, अत्यधिक लालावाह, सोतो (नीक, मुख आदि) में उपदिग्धता (कफ से आच्छादित होने की अनुभूति) के कारण निद्रा, कल्म, श्वास, कास, प्रसेक तथा तम आदि (व्याधियाँ) उत्पन्न हो जाती हैं।

The *ślesmā* getting aggravated due to use of *guru* (heavy) etc. articles, reaches breasts. This *kapha* by its unctuous property makes the milk excessively unctuous.

The child sucking this milk suffers from vomiting, tenesmus, excessive salivation, as his *śrotasas* (channels) are constantly smeared or covered thus suffers from excessive sleep, has tiredness, dyspnoea, cough, excessive expectation or discharges and darkness.

(७) पिच्छिल स्तन्यदुष्टि के निदान एवं पानोत्पन्न व्याधियाँ (Etiopathogenesis and clinical manifestations of picchila or stinky milk)

अभिपूय कफः स्तन्यं पिच्छिलं कुरुते यदा। लालातुः शूनवक्त्राक्षिर्जडः स्यात्तत् पिबच्छिशुः ॥

(च० सं० चि० ३०/२४८ व २४९)

(उपर्युक्त कारणों से कुपित) कफ स्तन्य को अभिपूय करके उसे (अति) पिच्छिल कर देता है।

पान करने से शिशु को अत्यधिक लालावाह, मुख एवं आँखों में शोथ तथा जड़ता आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

The *kapha* vitiated due to above mentioned causes overpowers the milk and makes it excessive *picchila* (stinky).

The child consuming this milk suffers from excessive salivation, edema of eyes and face and dullness.

(८) गुरु स्तन्यदुष्टि के निदान एवं पानोत्पन्न व्याधियाँ (Etiopathogenesis and clinical manifestations of guru or heavy milk)

कफः क्षीराशयगतो गुरुत्वात् क्षीरगौरवम् ॥

करोति गुरु तत् पीत्वा बालो हृद्रोगमुच्छति। अन्यांश्च विविधान् रोगान्कुर्वात्क्षीरमभिभ्रतम् ॥

(च० सं० चि० ३०/२४९, २५०)

क्षीराशय में पहुँचा हुआ कफ अपनी गुरुता के कारण दूध में भी गुरुता उत्पन्न कर देता है।

इसके पान करने से बालक को हृद्रोग हो जाते हैं तथा यह दूध से होने वाले अन्य भी अनेकों रोगों को उत्पन्न करता है।

The aggravated *kapha* reaching the breasts makes the milk *guru* (heavy) due to its own heaviness.

The child sucking this milk suffers from *hṛdroga* (cardiac disorders) as well as other disorders of milk.

हारीतसीहिता वर्णित पञ्च क्षीरदोष (Five milk disorders described by Hārītā)

पञ्चैव क्षीरदोषश्च स्त्रीणाञ्च कथिता बुधैः। घनक्षीरोष्णक्षीरास्तृक्षीरा चैव तथा परा ॥

अल्पक्षीरा क्षारक्षीरा मृदुक्षीरा तथा परा। मृदुक्षीराभवेत्सौख्या पञ्चान्या दोषकारकाः ॥

(हा० सं० तु० स्या० ५४/१, २)

विद्वानों ने स्त्रियों के पाँच ही क्षीरदोष कहे हैं। स्त्रियाँ घनक्षीरा, उष्णक्षीरा, अल्पक्षीरा, क्षारक्षीरा तथा मृदुक्षीरा होती हैं। इनमें से मृदु क्षीर वाली स्त्री (बालक के लिए) सुखकारक होती है, अन्य पाँच प्रकार के क्षीर दोषोत्पादक होते हैं।

(१) घनदोष युक्त क्षीरपान जन्य व्याधियाँ

घनाधाननिरोधत्वं श्रवासकासादिसम्भवः। अरुणकुक्षितैवं हि घनक्षीरस्य सेवनात् ॥

(हा० सं० तु० ५४/३)

घन विकार-युक्त क्षीर के सेवन से अत्यधिक आध्मन, निरोध (मल, मूत्र एवं वायु का निरोध), श्वास, कास आदि होने की सम्भावना रहती है तथा कुक्षि (पेट) फूल जाती है।

(२) अल्पदोष युक्त क्षीरपान जन्य व्याधियाँ

अल्पसत्त्वः कुशो दीनः श्रवासातीसार पीडितः। अल्पक्षीरस्य दोषेण सम्भवोद्धतवाक्मुतः ॥

(हा० सं० तु० ५४/४)

अल्पदोष युक्त (अल्प मात्रा के) दुग्ध के सेवन से बालक के कुश, दीन (दुर्बल), खस एवं अतिसार से पीड़ित होने की सम्भावना रहती है तथा उसकी बाणों का नाश हो जाता है।

(३) उष्णदोष युक्त स्तन्यपान जन्य व्याधियाँ

चक्र: शोषसथरात्मन्मुष्णक्षीरेण बालके। तथैव चोष्णक्षीरेण च्चरातीसार एव च॥
(हृ० सं० तु० ५४/५)

उष्णदोष से दूषित क्षीर के पान से बालक को चक्र, शोष तथा अल्पत्व (शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में अल्पता) हो जाते हैं। उसी प्रकार उष्ण क्षीर से च्चरातिसार भी हो जाता है।

(४) क्षारदोष युक्त स्तन्यपान जन्य व्याधियाँ

चक्षुरोगश्च कण्डूश्च क्षतरलेभावस्त्राविता। संकलेदयुक्तं नासास्यं जायते क्षारदुग्धके॥
(हृ० सं० तु० ५४/७)

क्षारदोष युक्त दुग्ध के सेवन से बालक को चक्षुरोग, कण्डू, क्षत, रलेभा का साव (मुख एवं नासिका से कफ का निकलना) तथा नासिका एवं मुख का कलेद-युक्त होना आदि व्याधियाँ हो जाती हैं।

(५) अम्ल दुग्ध के सेवन से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का कोई वर्णन नहीं है।

उष्णक्षीर के वर्णन में एक ही श्लोक में "उष्णक्षीरेण" शब्द दो बार आया है। इसी पुनरावृत्ति अन्तर्गत कहीं दुष्टिगोचर नहीं होती, संख्या-गणना में उष्ण के बाद अम्ल का उल्लेख है अतः यदि "चोष्णक्षीरेण" के स्थान में "चाम्लक्षीरेण" पाठ कर दें तो पुनरावृत्ति दोष समाप्त हो जायगा तथा अम्लदोष युक्त क्षीरपान से च्चरातिसार की उत्पत्ति भी मानी जा सकेगी। वैसे रस के आधार पर, अम्लपित्त, पाण्डू या कामला की भी उत्पत्ति मानी जा सकती है।

The wise persons have enumerated only five disorders of milk of a woman. The woman possesses *ghana* (thick), *usna* (hot), *amla* (sour), *alpa* (scanty), *kṣāra* (alkaline) or *myrda* (soft) milk. Only those woman having *myrda* milk are pleasurable/felicitic/comfortable to the child. All other five types of milk cause diseases and produce following symptoms.

S. No.	Abnormality of milk	Diseases produced to the sucking child.
1)	<i>Ghana</i> (thick)	May have excessive flatulence, suppression of feces, urine and flatus, dyspnoea, cough and gets distension of abdomen.
2)	<i>Alpa</i> (scanty)	May suffer from emaciation, misery, dyspnoea, diarrhoea and becomes aphonic.
3)	<i>Usna</i> (hot)	Fever, emaciation, retardation of growth and development and also diarrhoea with fever.
4)	<i>Kṣāra</i> (alkaline)	Eye disorders, itching, ulcers, excessive mucoid discharges from mouth and nose and excessive humidity of nose and mouth.
5)	<i>Amḷa</i> (sour or acidic)	Not described.

In the description of *usnakṣīra* the word '*usnakṣīrena*' has been mentioned twice in

the same verse, this type of repetition is not seen else where. In enumeration of disorders '*amḷa*' is mentioned just after '*usna*'. If '*usna*' word of second line is replaced with '*amḷa*', then the question of repetition will not arise and reference of clinical manifestation i.e. fever with diarrhoea due to use of *amḷa* (sour) milk can also be seen. On the basis of particular *rasa*, hyperacidity, anemia and jaundice can be imagined to be developing by use of sour milk.

विमर्श (Comments)

संहिताओं में वर्णित विभिन्न रसों एवं बाणों का प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर निश्चित स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है, फिर भी बालक में होने वाले प्रभावों के आधार पर ऐसा मान सकते हैं कि समस्त वातजन्य स्तन्य-दुष्टियाँ दुग्ध में स्थित पोषक तत्वों के अभाव को प्रदर्शित करती हैं, जिसके पान से बालक में कुशला आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। रलेष्म-जन्य स्तन्य-दुष्टि में सम्भवतः दुग्ध में अपेक्षकृत वसा की मात्रा अधिक होती है, या कुछ अपचनीय द्रव्य उपस्थित रहते हैं जिसके पान से बालक को वमन तथा अन्य रलेष्म-विकार हो जाते हैं। यह भी सम्भव है कि इस दुग्ध से शिशु को पालनानामक क्रिया (एलर्जिक मैनिफेस्टेशन) होती हो, जिसके कारण मुखशोफ आदि व्याधियाँ एवं वमन हो जाता हो। पित्तज स्तन्य-दुष्टि, स्तन्य-स्थित उपसा, शोथ या विद्रधि के कारण रक्त या पूर्य मिश्रित होने से उत्पन्न प्रतीत होती है। द्रव्यज एवं सान्निपातिक में दोष-प्राबल्य के आधार पर उपर्युक्त का समिन्ध्रण होगा। कारयस्सहिता वर्णित ग्रह-जन्य स्तन्यदुष्टि का स्पष्टीकरण विषय के अतिरिक्त वर्णन के कारण कठिन है। महर्षि हारीत वर्णित पञ्चक्षीर दोषों का अन्य संहिताओं में वर्णित दोषिक स्तन्यदुष्टि के अन्तर ही समावेश हो जाता है यद्यपि अल्पदोष का वास्तविक, घन का कफज तथा उष्ण एवं अम्ल का वैतिक में अन्तर्भाव हो जाता है। यद्यपि क्षार गुण वाल का होगा कफ का नहीं, परन्तु उत्पन्न व्याधियाँ कफ के ही समकक्ष लगती हैं अतः इसे वातकफज मान सकते हैं।

On the basis of practical observations, it is not possible to offer any probable explanation for various colours and tastes of milk described in *āyurvedika* classics. However, considering only clinical manifestations produced in the child, it can be presumed that probably all the milk disorders produced by *vāta* reflect some deficiency of nutrients in the milk, naturally the child consuming this milk suffers from emaciation etc. disorders produced due to under-nourishment. Probably in all the milk disorders caused by *kapha* the milk contains relatively more amount of fat or any such thing which child can not digest, thus vomits the milk or else the child is allergic to this milk, thus, either ejects it or suffers from edema of face etc. disorders. In milk disorders caused by *pitta*, probably the milk carries bacteria or blood or pus from inflammation or abscess of breast. This infection produces fever etc. in the child. Since the description of *Kāśyapa Samhitā* about milk disorder caused by *grāhas* is very short, hence probable congruence can not be established.

On the basis of physical character of milk explicit by their names and clinical manifestation produced, all the five disorders described by Hārīta can be included under the disorders caused by *dosas*, such as *alpa dosa* may be considered under *vātika*; *ghana dosas* under *kaphija*; *usna* and *amḷa dosas* under *pittija* disorders. Though the *kṣāra* is a property of *vāta*, however, the symptoms of the child show the features of *kapha* thus it may be considered as *vādakaphija*.

स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (Treatment of stanyaduṣṭi or vitiation of milk)—

यद्यपि स्तन्य-दुष्टि धात्री की व्याधि है, पर उससे आक्रांत या पीड़ित होता है कुमार। क्योंकि स्तन के द्वारा दोष

बालक में पहुँच कर बालकों को मुण्डपाक एवं धात्री को ज्वर इत्यादि कर देते हैं^१। अतः चिकित्सा करते समय धात्री के साथ ही बालक को भी चिकित्सा करनी पड़ती है। बालक को औषधि भी चूचुक द्वारा ही बलपूर्वक दी जाती है^१। बालकों की चिकित्सा बालरोग का विषय होने के कारण यहाँ वर्णित नहीं की जा रही, फिर भी कुछ धात्री-चिकित्सा वर्णन के हो बीच में आचार्यों ने कहीं कहीं बालकों की भी थोड़ी बहुत चिकित्सा या चिकित्सा सिद्धान्तों का उल्लेख कर दिया है। संहितातन्त्रांतर्गत धात्री-चिकित्सा-वर्णन के संदर्भों को पूर्णरूपेण उद्धृत करने के उद्देश्य से एकाध बालचिकित्सा का भी वर्णन कर दिया गया है। विस्तृत बालचिकित्सा का नहीं।

Though vitiation of milk occurs in the body of mother/wet nurse, yet the abnormalities caused by this are produced in the child, because the *dosas* reach the child from breast and produce stomatitis to the child and fever to the wet-nurse, naturally while managing the milk disorders, mother/wet-nurse and child both are to be treated simultaneously. Medicine to the child is mainly given through teats of the mother. Treatment of children comes under the jurisdiction of pediatrician, naturally that is not being described here. However, certain principles of treatment or recipes prescribed for children are almost inseparable from the description of treatment of wetnurse. In order to recapitulate complete management of wet nurse, few such references for children are also included. Detailed description of treatment for the child is not being given here.

चिकित्सा सिद्धान्त (Principles of treatment)

तेषां तु त्रयाणामपि क्षेत्रदोषाणां प्रतिविशेषमभिस्मीक्ष्य यथास्वं यथादोषं च वमनविचनस्थानानुवासनानि विषम्य कृतानि प्रथममाय भवन्ति ॥ (च० सं० शा० ८/५६)

तत्रादौ स्तन्यशुद्धयर्थे धात्रीं स्नेहोपपादिताम् ॥ २५१॥

संस्वेद्य विधिवद्बद्धो वमनेनोपपादयेत् ॥ २५२॥

सम्यग्वातां यथान्यायं कृतसंस्पर्शनं ततः ॥ २५३॥

दोषकालबलापेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत् ॥ २५४॥

सम्यग्विचरित्वा मतिमान् कसंसर्जनां पुनः ।

ततो दोषावशेषेनैरत्रपानैरुपाचरेत् ॥ २५६॥ (च० सं० चि० ३०)

स्तन्ये गते विकृतिमाशु भिषक् तु धात्रीं पीतां घृतं परिणतेऽहनि वामयेत् तु ॥ ४२॥

निम्बोदकेन मधुमगधिकारयुतेन वान्नागतेऽहनि च मुद्गरासाशना स्यात् ।

एवं गृहं चतुरहं षडहं वमेद् वा सर्पिः पिबेत् त्रिफलया सह संयुतं वा ॥ ४३॥

सामान्यमेतदुपदिष्टमतो विशेषाद्, दोषान् पयोनेपतितान् शमयेद् यथास्मत् ॥ ४५॥

(सु० सं० चि० १७/४२, ४३, ४५)

अथ यथामयं यथादोषं च धात्र्याः शमनशोधनानि प्रयुञ्जीत ॥ (अ० सं० उ० २/१०)

अथ धात्र्याः क्रियां कुर्याद्यथादोषं यथामयम् ॥ (अ० ह० उ० २/९)

कषायपानेनैवैविरिकैः पथ्यभोजनैः । वाजीकरणसिद्धेऽथ स्नेहैः क्षीरं विशुध्यति ॥ ५॥

(कफ० सं० सू० ११)

१. स्तनमौ। रयते ॥ १३॥

मुण्डपाकं च बालानां कुर्मज्जया ज्वरं तथा । तस्माद्बलादिवायुज्ज्वलाद्यादोषां शिशोः ॥ १४ ॥ (का० सं० सि० ३)

उन सभी तीनों प्रकार के स्तन्य दोषों में, उनकी प्रतिविशेषता को देखकर (अर्थात् प्रत्येक वातादि दोष का कोष्ठश्रयित्व, उदीर्णत्व, शोधन के लिए उपयुक्तता आदि विशेषताओं को देखकर^१), यथास्व (अर्थात् कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन तथा वात के लिए आस्थापन एवं अनुवासन वस्ति^२) एवं यथादोष (अर्थात् प्रवृद्ध दोष में अत्यधिक मात्रा का संशोधन तथा अन्य कुपित दोष में अन्य शोधन^३) वमन, विरेचन, आस्थापन एवं अनुवासन आदि का विभाजन कर प्रयोग करने से शमन होता है, अर्थात् वे स्तन्य-दोष ठीक हो जाते हैं। टीकाकार चक्रपाणि के अनुसार धात्री की प्रकृति को भी देखकर वमनादि का अधिक या कम प्रयोग करना चाहिए^१।

महर्षि चक्र पुनः लिखते हैं कि स्तन्य को शुद्ध के लिए स्नेह प्रयोग की हुई धात्री का स्वेदन करके, वमन करावें। भलीभाँति वमन हो गई हुई (धात्री को) नियम पूर्वक संस्पर्जनक्रम करके, स्नेहन कराकर, दोष, काल एवं बल का ध्यान रखते हुए विरेचन करावें। बुद्धिमान वैद्य भलीभाँति विरेचन हो जाने के पश्चात् पुनः संस्पर्जनक्रम करके, बाद में अवशेष दोषों के (शोधनादि से पूर्णरूपेण बाहर न निकले हुए दोषों के) नाश (शमन) के लिए (शामक) अत्र-पान का प्रयोग करावें।

महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा है कि स्तन्य में विकृति हो जाने पर भिषक् घृत पी हुई स्त्री को सायंकाल मधु एवं मगधिका मिश्रित निम्ब-क्वाथ पिलाकर वमन करावें। वमन कराने वाले दिन के बीच जाने पर मुद्गरास आदि का भोजन दे। इस प्रकार तीन, चार अथवा ६ दिन वमन तथा त्रिफला-शुक्र घृत का पान कराना चाहिए, यह स्तन्य-दोषों की सामान्य चिकित्सा है। स्तन्य-विकारोत्पादक दोषों के प्रकोप के आधार पर उनकी यथास्व (कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन, वात के लिए बस्ति) आदि विशिष्ट चिकित्सा करनी चाहिए। टीकाकार डल्हण ने कफघ्न द्रव्यों से संस्कृत या शमन द्रव्यों से साधित घृत पी हुई धात्री को 'परिणतेऽहनि' से सायंकाल अर्धं कर्क इसी काल में वमन कराने का निर्देश दिया है, तथा सामान्यतया स्नेहपान के लिए वर्णित स्वर्ण सदृश पीले या लोहित, प्रस, सूर्यकाल (प्रतःकाल) का धात्री के लिए अपवाद बताया है अर्थात् यह काल धात्री के लिए उचित नहीं है। जेज्जट आदि ने 'परिणत' शब्द से 'स्नेहफल की निष्पत्ति' अर्थ करके, स्नेह के प्रयोग से स्निग्ध स्त्री को उसी दिन वमन कराने का वर्णन दिया है। परन्तु 'गयी', का विचार है कि यह गलत है क्योंकि सामान्य वाक्य से ही स्निग्ध को वमन कराना गौर्हित है (अर्थात् गयी, डल्हण के स्पष्टीकरण को ही उचित मानते हैं)। स्नेहन के पश्चात् स्वेदन कर के वमन देना चाहिए। वमन वाले दिन ही भोजन नहीं देना चाहिए, उसके अगले दिन देना चाहिए। पहिले वमन से कफ का पूरा निस्सरण न होने से अशुद्ध देह वाली स्त्री को स्नेह एवं स्वेद का बीच बीच में प्रयोग करके तीन, चार या ६ दिन या जब तक देह शुद्ध न हो जाय, वमन कराना चाहिये। देह के शुद्ध हो जाने पर वमन का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री को गतानि तथा स्तन्यक्षय हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध देह धात्री को बात एवं पित्त के अनुबन्ध में (अर्थात् इन दोषों का अनुबन्ध दूर करने के लिए) स्नेहपाक परिभाषा के अनुसार त्रिफला से सिद्ध घृत का पान कराए। यह घृतपान उस धात्री को व्यवस्थित अर्थात् स्वस्थ करता है^३।

अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि व्याधि एवं दोष के अनुसार धात्री को शमन एवं शोधन चिकित्सा देनी चाहिए।

१. प्रतिविशेषमभिस्मीक्ष्येति प्रति प्रति बालादीनां कोष्ठश्रयित्वोदीर्णत्वादिशोधनगुणं विशेषधीवीक्ष्य । यथान्तरित्वेन रलेष्यणि वमनं, पित्ते विरेचनं, वायावायुपानानुवासेन, इति आत्मन्यपामनीयं संशोधनं दर्शयति । यथादोषमित्यनेन प्रवृद्धे दोषेऽतितानं संशोधनं, स्तोके स्तोकाग्रं दर्शयति । । 'प्रकृतिविशेषम्' इति यदा पाठस्तदा प्रकृतिविशेषमपि धात्र्या अवैश्य वमनादीनां बहुलत्वप्रविशेषः कर्तव्य इत्यर्थः ॥ (च० सं० शा० ८/५६ की चक्र० टीका)

२. परिणतेऽहनि सायंकाले, पीतां घृतं संशमनेव घृतं पीवतीम्, एतच्च प्रतसकन्कीकरणीतोहिने सवितरि स्नेहपाकस्तस्यापवादः । सामान्योक्तमपि कफघ्नद्रव्यसंस्कृतं घृतम् । जेज्जटद्वयसु परिणते निषङ्गे स्नेहफले सति स्निग्धमित्यर्थः, अहनि तस्मिन्नेव दिवसे । तत्रेच्छति गयी, सामान्यवाक्येनैव स्निग्धाय वमनस्य विहितत्वात् । रिक्यां निम्बोदकेन निम्बक्राशेन वामयेत् । वान्नागतेऽहनि च मुद्गरासाशना स्यात् न तु वमनदिवसे भोजयेदित्यर्थः । तत्र प्रथमवमने कफस्य निःशेषमपह्नत्वाशुद्धदेहो स्नेहस्वेदनावाऽन्त्या सेवयित्वा षडहं वा चतुरहं गृहं वा यावत् विशुद्धीरिति, शुद्धदेहयत्तसु पुनर्वमनं त्याज्यम्, अन्यथा गतानिः स्तन्यक्षयश्च । तस्मात् शुद्धदेहया वान्तिपानानुबन्धे स्नेहपाकपरिभाषया त्रिफलासिद्धं सर्पिः पिबेदेवेति वा शब्दात् व्यवस्थितायां लभ्यते ॥ (सु० सं० चि० १७/४२ की डल्ह० टीका)

अष्टाङ्गहृदयकार ने भी व्याधि एवं दोषानुसार ही कर्म करने का निर्देश दिया है।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि कायान-पान, वमन, विरेचन, पथ्य-भोजन तथा वाजीकरण द्रव्यों से सिद्ध स्नेह के प्रयोग से स्तन्य का शोषण होता है।

स्तन्यदोष वमन-योग्य कहे गए हैं^१ अर्थात् इनमें वमन देना चाहिए।

While managing the vitiation of milk caused by either of the *dosas*, specific attention should be paid to the peculiarity of *dosas* i.e. its situation in *koṣha* (viscera) or *śūkha* (extremities), the intensity of vitiation and also suitability for use of purifying measures. According to the amount of vitiation of *dosas* (in excessive aggravation strong or drastic purification and in slight aggravation mild purification) specific purifying measures i.e. emesis in *kapha*, purgation in *pitta* and *āsthāpāna* and *amavāsana basti* (evacuative and nutritive enemas) in vitiation of *vāta* should be given. Besides *dosas*, the *prakṛti* (nature) of wet-nurse should also be taken into account during use of purifying measures. With the use of these specific purifying measures, the aggravated *dosas* are suppressed and vitiation of milk is corrected.

The wet-nurse having already been given *snehana* (use of oleaginous substances) should be given sudation followed by emesis. After proper emesis, methodical *samsarjana-krama* (use of diet in gradual manner i.e. first *peya* or liquid then *maṇḍa* or scum of boiled rice then *vilepi* or rice-gruel etc.) should be done and then, after readministering *snehana*, the *virēcana* (purgative drugs) should be given, giving due consideration to vitiated *dosas*, *kāla* (period or time of disease) and *balā* (strength of the woman). After proper purgation and reapplication of *samsarjana krama*, the wise physician should prescribe such diet which can suppress the *dosas* left-over after purification.

Suśruta says that to the wet-nurse after giving *ghṛta*, emesis should be induced in the evening by oral administration of decoction of *nimba* mixed with honey and *māgadhikā*. Next day soup of *mudga* should be given in diet. In this way emesis should be induced for three, four or six days. This should follow use of *ghṛta* medicated with *triphalā*. This is general treatment. Specific treatment should be given on the basis of *dosas*. Dalhana has clarified that the *ghṛta* to be given before emesis should be prepared with the drugs capable of suppressing either the *kapha* or *samana* drugs (drugs having properties of suppressing the *dosas*). Usual period i.e. in the morning when sun is red or golden, normally suitable for administration of *ghṛta*, is exception for wet nurse or is not suitable for her. Naturally, it is to be given in the noon. After oleation, the sudation should also be given before emesis. On the day of emesis diet should not be given. Emesis preceded with oleation and sudation should be continued for three, four or six days till the *kapha* is completely expelled and body is fully purified. Once the body is purified, the emesis should be stopped, otherwise

१. अ) शेषास्तु बाम्नाः..... दुष्टस्तन्मादयः। (च० सं० सि० २/१०)

आ) बाम्नास्तु..... स्तन्यदोष। (सु० सं० सि० ३३/१८)

इ) तत्र वमनसाध्या..... स्तन्यदोषादयो। (अ० सं० सू० २७/६)

ई) विशेषणं तु बामयेत् ॥ स्तन्यदोषोर्वर्जित्वाः ॥ (अ० ह० सू० १८/२, ३)

ए) स्तन्यरोगे वमनं कारयेद्विषक् ॥ (शा० सं० उ० ख० ३/३, ५ एव षा० प्र० पूर्व० ५/६)

the woman will become languid and quantity of her milk will also decrease. *Triphalāghṛta* used after this emesis suppresses associated *vāta* and *pitta*, besides, this also makes the wet-nurse healthy.

Both the *Vāḍbhatas* have also advised purification according to vitiation of *dosas*.

Kāśyapa opines that milk is purified by use of decoction, emesis, purgation, congenial diet and *ghṛta* medicated with *vājīkaraṇa* drugs.

धात्री वमनार्थ औषधि (*Emetics to be prescribed for wet-nurse*)

वचाप्रियङ्गुयष्ट्याह्वफलवत्सकसर्षपैः ॥ २५२॥

कल्केनिम्बपटलानां क्राशैः सत्वर्णोर्वेत् ॥ २५३॥ (च० सं० सि० ३०)

निम्बोदकेन मधुमाषाधिकारुजेन.....। (सु० सं० सि० १७/४३)

वचा, प्रियङ्गु, यष्ट्याह्व, फल, वत्सक एवं सर्षप के कल्क को निम्ब (त्वक्) एवं पटोल (पत्र) के क्राश के साथ लवण (सैन्धव) मिलकर वमनार्थ देना चाहिए।

महर्षि सुश्रुत ने मधु एवं माषिका युक्त निम्ब-क्राश का वमनार्थ प्रयोग बताया है।

i) Paste of *vaca*, *priyangu*, *yastyaḥwa*, *phala*, *vatsaka* and *sarśapa* mixed with the decoction of stem bark of *nimba*, leaves of *patola* and rock salt should be given to induce emesis.

ii) Decoction of stem bark of *nimba* mixed with honey and *māgadhikā* can be used for emesis.

धात्री विरेचनार्थ औषधि (*Purgatives for wet-nurse*)

त्रिवृतामभयां वाटपि त्रिफलारससंयुताम् ॥ २५४॥

पायदोन्मथुसंयुक्तामभयां वाटपि केवलाम्।

(पायदोन्मथुसंयुक्तां विरेचार्थं च शास्त्रवित्) ॥ २५५॥ (च० सं० सि० ३०)

त्रिवृत् अथवा अभया को त्रिफला रस (त्रिफला-क्राश) के साथ अथवा केवल अभया (चूर्ण) को मधु के साथ दे। शास्त्रज्ञात विद्वान् अभया के चूर्ण को मूत्र (गोमूत्र) में घोलकर पिलावे।

i) Powdered *trivṛta* or *abhaya* with decoction of *triphalā*.

ii) Powdered *abhaya* with honey.

iii) Powdered *abhaya* mixed with cow urine.

पथ्य (*Congenial diet to the wet-nurse during treatment of vitiation of milk*)

पानाशनविधिस्तु दुष्टक्षीराया यवगोधूमशालिषाष्टिकमुद्गाहरेणुककुलस्थसुसासौवीरैर्यवेकलशुनकराज्जप्रायः स्यात्। क्षीरदोषविशेषाश्चोर्वेद्यस्तद्विधानं कार्यं स्यात्। (च० सं० शा० ८/५६)

शालयः षष्टिका वा स्युः श्यामाका भोजने हिताः। प्रियङ्गवः कोदण्डा यवा वेणुयवास्तथा ॥

वश्यवेकलयाश्च शाकार्यै स्नेहसंस्कृताः। मुद्गान् मसूरान् पूषार्थं कुलस्थांश्च प्रकल्पयेत् ॥

निम्बवेत्राप्रकुलकवार्ताकामलकैः शृतान्। स व्योषसैन्धवान् यूषन्पायस्त्वस्तन्यशोषनाम् ॥

शशान् कपिञ्जलानेभान् संस्कृतांश्च प्रदापयेत् ॥ (च० सं० सि० ३०/२५७ से २६०)

मसूरः षष्टिका मुद्गाः कुलस्थाः शालयो घृतम्। गव्यमाजं पथः काले लवणं चाप्यनौद्धिदम् ॥१६॥

आहारविधिरष्टिः स्तन्यशोधनकालिकः ॥ १७ ॥ (का० सं० सू० १९)

दुग्ध दुग्ध वाली स्त्री को पानाशन के लिए यव, गेहूँ, शालि एवं षष्टिक (चावल), मुद्गा, हरेणुक, कुलत्थ, सुता, सौवीरक, सैय्य एवं मेदक (विभिन्न प्रकार की सुतायें), लशुन और करञ्ज देना चाहिए। श्वीरेणु को देखकर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए अर्थात् बड़े हुए दोषों के प्रतिकूल आहार का विधान करना चाहिए।

पुनश्च महर्षि चरक लिखते हैं कि शाली, षष्टिक, श्यामक (साँवा), प्रियङ्गु, कोट्दध, यव तथा वेणुयव (बाँस का जौ) भोजन के लिए हितकारी हैं। शक के लिए वंश, वेत्र (बाँस के अङ्कुर एवं बेंत का अग्रभाग) तथा कलाय को स्नेह से संस्कृत करके तथा यूष के लिए मुद्गा, मसूर तथा कुलत्थ का प्रयोग करें। निम्ब, वेत का अग्रभाग, कुलक, वार्ताक तथा आमलक में शृत (इनके स्वरस या क्राथ के साथ पका), ज्योष तथा सैन्धव मिलाए हुए स्तन्य-शोधक यूषों का प्रयोग करना चाहिए। शक्क, कपिञ्जल (तिरि) तथा एण (विशिष्ट हिण) का संस्कृत मांस देना चाहिए।

महर्षि काश्यप ने लिखा है कि स्तन्य-शोधन काल में मसूर, षष्टिक, मुद्गा, कुलत्थ, शालि (चावल), धृत, गौ तथा बकरी का दुग्ध, समय पर भोजन, अनौद्भिद (कृत्रिम या सैन्धव) लवण आदि का आहार में प्रयोग करना चाहिए।

आचार्य भावमिश्र ने लिखा है कि धात्री को स्तन्य-शोधन के लिए मुद्गा का यूष तथा रस (मांसरस) का सेवन करना चाहिए।

Giving due consideration to the vitiation of milk such dietetics should be prescribed which are opposite in the qualities of aggrivated dosas.

Following are the congenial things to be used in diet or drinks by the woman having vitiation of milk i.e. barley, wheat, *śālī* and *saṣṭika* (varieties of rice), *veṇu yava* (seeds of bamboo), *śyāmāka* (a kind of millet), *pryāṅgu* (italian millet) and *koṭadha* (little millet), etc. cereals; sprouts of bamboo, tip of *vetra* and leaves or seeds of *kalyā* as vegetables after proper preparation and mixing with fat; *mudga* (a kind of bean), *haraviṅka* (pea), *kulathā* (horse-bean) and *masūra* (pulse of lentil) for preparation of soup; *surā*, *sauvīraka*, *maireya* and *medaka* (different types of wines) etc. wines and *lāsūna* (garlic) and *kavayā*. Soups cooked with juice or decoction of *nimba*, tip of *vetra*, *kulaka*, *vārāka* and *amalakā* and mixed with *vyōsa* and rock salt should be used. Properly medicated meat of rabbit, partridge and *eṇa* (variety of deer) should be given for eating.

Kāśyapa says that during the period of purification of milk (*stanyasodhana*) *masūra*, *saṣṭika*, *mudga*, *kulathā*, *śālī* rice, *ghṛta*, milk of goat or cow, timely eating and rock salt etc. should be used.

Bhāvamiśra has enumerated only soup of meat and *mudga* in the list.

अपथ्य (Non-congenial or harmful things)

गुर्वस्त्रेणैवमांसानि दिवास्त्रयं च वर्जयेत् ॥ १७ ॥ (का० सं० सू० १९)

गुरु अन्न, स्नेह, मांस तथा दिवास्त्रय का परित्याग करना चाहिए, स्तन्यदोष-पीडित धात्री को मण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

१. तद्विधानं कार्यं स्यादिति तत्तद्वृद्धोपप्रतिकूलमहाराजविधानं कार्यं स्यात्। (च० सं० शा० ८/५६ को चक्र० टीका)
२. धात्रीशीतलुद्रयार्थं मुद्गायूषसाशिनी ॥ (भा० प्र० पूर्व० ४/२०)
३. धान्याः प्रचुद्धे पयसि प्रचुद्धे मण्डं भिषग्दोषपरिशेषिष्विह ॥ (का० सं० कल्प० ७/६७, ६८)

Guru (heavy) cereals, oleaginous substances, meat and day sleeping should be discarded as these are harmful. *Māṇḍa* (seum of boiled rice) is also noncongenial.

विमर्ष (Comments)

पथ्यान्तर्गत महर्षि काश्यप ने गृत एवं अन्य आचार्यों ने मांस का समावेश किया है। काश्यप संहिता में पुनः ये वस्तुयें अपथ्य लिखी हैं, सम्भवतः अपथ्यान्तर्गत वर्णित स्नेह एवं मांस से आचार्य का गुरु स्नेह (महिषी घृत आदि) तथा गुरु मांस (औद्भिद आदि जीवों का मांस) तात्पर्य हो।

Since *ghṛta* and meat have already been included under congenial diet, hence here *guru ghṛta* (heavy *ghṛta* as of buffalo etc.) and *guru māṇḍa* (meat of aquatic etc. animals) should be considered as harmful.

स्तन्यदुष्टि की सामान्य चिकित्सा (General treatment of vitiation of milk)

(अ) स्तन्य शोधक द्रव्य (Drugs possessing milk-purifying properties)

पाठमहर्षिषधसुरादरुमुस्तपूर्वागुडचीवत्सकफलकिरातनिककटुगोहिणीसारिवा इति दशोमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति ॥ (च० सं० सू० ४/१८)

पाठा, महर्षिषध, सुरादरु, मुस्त, मूर्वा, गुडूची, वत्सकफल, किरातनिक, कटुगोहिणी तथा सारिवा ये दस द्रव्य स्तन्य-शोधक होते हैं।

Pāṭhā, *maharṣiṣha*, *surādāru*, *muṣṭa*, *mūrvā*, *guḍūci*, fruit of *varsaka*, *kīrātārita*, *kaiṛōhiṇī* and *sāriwā* these ten drugs are known as *stanyasodhaka* (milk purifying) drugs.

आ) अन्य औषधियाँ (Common preparation for treatment of vitiation of milk)

(१) पाठा, महर्षिषध, सुरादरु, मुस्त, मूर्वा, गुडूची, वत्सकफल, किरातनिक, कटुगोहिणी तथा सारिवा (उपयुक्त वर्णित स्तन्यशोधक द्रव्य) आदि सभी का पृथक पृथक अथवा एक साथ अथवा गुडूची के अतिरिक्त अन्य सभी द्रव्यों का कषाय (क्वाथ) पान करना चाहिए।

(२) दुग्ध के विशिष्ट विकार या दोष-प्राधान्य, विकृति की मात्रा तथा दुष्टि के काल का विचार कर तिक, कषाय (पाठा आदि सभी कषाय द्रव्य), कटु एवं मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए।

(३) शार्ङ्गिष्ट, सप्तपर्ण की छाल तथा अरुणांघा का क्वाथ पीने को दें।

(४) रोहिणी का क्वाथ पीने को दें।

(५) अमृता, सप्तपर्ण-त्वक् एवं नागर का क्वाथ पानार्थ दें।

(६) किरातनिक का क्वाथ पीने को दें।

(७) भार्गी, क्वा, अतिविषा, सुरादरु, पाठा, मुस्तादि गण, मधुरसा तथा कटुगोहिणी के क्वाथ का पान करें।

(८) आरावध्यादि गण की औषधियों का कषाय मधु के साथ पीना श्रेष्ठ है।

(९) मूर्वा, ज्योष, वरा (त्रिफला), कोल, जम्बूत्तक, दारु, सर्षप एवं पाठा के चूर्ण को मधु के साथ चाटना या इन द्रव्यों के साथ चवा मिला कर पीस कर एक प्रसृत की मात्रा में ले मधु मिश्रित कर पीना चाहिए।

नोट-सन्दर्भ पृष्ठ ६९९ में देखें।

है^४ ।

(१०) पाठा, शुण्ठी, अमृता, तिका, देवाह, सारिवा, मुस्ता, मूर्वा तथा इन्द्रयव का क्राश उतम स्तन्य-दोष नाशक है^५ ।

(११) भृङ्गवेर एवं पटेल (पत्र के स्वरस) के साथ पिप्पली के चूर्ण का सेवन करें तथा पथ्य में यूष एवं लघु अन्न-पान का प्रयोग करें^६ ।

(१२) धातकीपुष्प, एला, समझा (मञ्जिष्ठा), मरिच, जम्बूत्क तथा मधुक (का चूर्ण या क्वाथ) उत्तम क्षीरशोधक है^७ ।

(१३) पाठा, महौषध, दारु, मूर्वा, मुस्ता, वत्सक, सारिवा, अरिष्ट, कटुका, कैराल, त्रिफला, वचा, गुडूची, मधुक, द्राक्षा, दशमूल, दीनोप द्रव्य, रक्षोच गण एवं पटेलोदि गण के द्रव्य आदि सभी स्तन्यशोधक हैं । इनमें से उपलब्ध द्रव्यों का क्वाथ पान करने से विरकालीन स्तन्यदोष भी दूर हो जाते हैं^८ ।

इस उपर्युक्त क्वाथ को कफप्रतिहत स्तन्यदुष्टि में मधु के साथ तथा अन्यो (वातज, पित्तज) में घृत के साथ सेवन करना चाहिए, कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा नहीं (घृत का सेवन) करें, क्योंकि (घृत) श्लेष्मा का स्थान है एवं क्षीर कफ से उत्पन्न हुआ है^९ ।

(१४) पिप्पली, पिप्पलीमूल, नागर, घन, वालुक, कुसुम्बुरु तथा मञ्जिष्ठा को दुग्ध के साथ कल्क करें, इस कल्क को क्षीर-शोधन के लिए पान करें, तत्पश्चात् मरिच एवं पिप्पलीमूल के चूर्ण को दुग्ध के साथ क्षीर-वर्धन के लिए प्रयुक्त करें^{१०} ।

(१५) भार्गो, दारु, वचा तथा अतिविषा को पीसकर पीना चाहिए^{११} ।

(१६) पटेल, निम्ब, असन, दारु, पाठा, मूर्वा, गुडूची, कटुरोहिणी तथा नागर का क्वाथ धात्री को दुग्ध को शुद्धि के लिए दें^{१२} ।

Following preparations should be prescribed for oral administration—

i) Decoction of above mentioned milk purifying drugs singularly or collectively or except *gudāci* other nine drugs.

ii) *Tika* (bitter), *kaṣṭhā* (*pāṭhā* etc. all astringent drugs), *kaiu* (pungen) and *mādhura* (sweet) drugs, on the basis of predominance of vitiated *dosa* and also period of vitiation or disease.

iii) Decoction of *śārngēṣṭā*, stem bark of *saptaparva* and *aśwagandhā*.

iv) Decoction of *rohinī*.

v) Decoction of *amrītā*, stem bark of *saptaparva* and *māgura*.

vi) Decoction of *kirāṭāṭika*.

vii) Decoction of *bhārngī*, *vacā*, *atviṣṭā*, *suradāru*, *pāṭhā*, *muṣṭādi* group of drugs, *mādhuraśā* and *kaiurohinī*.

viii) Decoction of *āragwadhādi* group of drugs mixed with honey.

ix) Powder of *mūrvā*, *vyoṣā*, *varā* (*triphalā*), *kola*, stem bark of *jambū*, *dāru*, *sarsapa* and *pāṭhā* mixed with honey or else with these drugs *vacā* pestled with water in the dose of one *prasṛta* and mixed with honey.

नोट-स्तन्य पृष्ठ ६१९ में देखें ।

x) Decoction of *pāṭhā*, *śūnṭhī*, *amrītā*, *tika*, *devāhwa*, *sārivā*, *muṣṭā*, *mūrvā* and *indrayava*.

xi) Powdered *piṅgali* with juice of *śārngabera* and leaves of *paṭola*, followed by use of soup, light diet and beverages.

xii) Powder or decoction of flowers of *dhātākī*, *elā*, *samaṅgā*, *marica*, stem bark of *jambū* and *mādhuka*.

xiii) Decoction of available drugs out of *pāṭhā*, *māhūsadhā*, *dāru*, *mūrvā*, *muṣṭā*, *vaṭasaka*, *sārivā*, *arṣṭā*, *kaiṭikā*, *kaiṭāta*, *triphalā*, *vacā*, *gudāci*, *mādhuka*, *drākṣā*, *daśamūla*, *dīpanīya* drugs, *rakṣoghaṭa* and *paṭolādi* group of drugs, is good milk-purifier and cures even chronic vitiation of milk.

Above mentioned decoction should be used with honey in case of milk vitiation caused

१. अ) पाठामहौषधमुस्तामूर्वागुडूचीवत्सकफलकिराततिककटुरोहिणीसारिवाकषायणां च पानं प्रशस्यते, तथाऽन्येषां तिककषायकटुकमधुरणां च द्रव्याणां प्रयोगः क्षीरविकारविशेषान्नीसमीक्ष्य मात्रां कालं च ॥ (कषायणामिति बहुवचनार्थं व्यस्तसमस्तानां पाठादीनां कषाय गृह्यन्ते-चक्र० टीका) (च० सं० शा० ८/५६)

अ) शार्ङ्गेष्टा सप्तपर्णत्वणधाराधृतम् ज्ञातम् ॥ २६० ॥

पायदेतश्च स्तन्यशुद्धये रोहिणीधृतम् । अमृतसप्तपर्णत्वक् क्राशं चैव सनागरम् ॥ २६१ ॥

किराततिककषाद्यं श्लोकपादेतिात् पिबेत् । त्रीनेतस्तन्यशुद्ध्यर्थमिति सामान्यभेषजम् ॥ २६२ ॥ (च० सं० चि० ३०)

२. भार्गो वचामतिविषां सुदारुपाठां मुस्तादिकं मधुसां कटुरोहिणीं च ।

धात्री पिबेत् तु पयसः परिशोधनार्थं, आरवधार्दिषु च मधुना कषायम् ॥ (सु० सं० चि० १७/४४, ४५)

३. मूर्वाव्योषधवकोलजम्बूत्कदारुसर्षपाः । समादा मधुना लीढाः स्तन्यदोषहाराः परम् ॥

(अ० सं० उ० २/३० एवं अ० ह० उ० २/३४, ३५)

४. पाठशुण्ठ्यमृतातिकिरादेवाहसारिवाः । समुस्तमूर्वेन्द्रयवाः स्तन्यदोषहाराः परम् ॥ (अ० ह० उ० २/२५)

५. त्रिफला सत्रिकटुका पाठा मधुरसा वचा । कोलचूर्णं त्वचो जाम्बा देवदारु च भेषितम् ॥ ६ ॥

सर्षप्रसुतोन्मिन्नं पातव्यं क्षीरसमुत्तम् । एतत् स्तन्यस्य दुष्टस्य श्रेष्ठं शोधनमुच्यते ॥ ७ ॥

भृङ्गवेरपटलाभ्यां पिप्पलीचूर्णचूणितम् । यूषपथ्यं विदध्याच्च ह्यजपानं च यश्च ॥ ८ ॥

धातकीपुष्पमेला च समङ्गा मरिचाणि च । जम्बूत्कवं समधुकं क्षीरशोधनमुत्तमम् ॥ ९ ॥

पाठा महौषधं दारु मूर्वामुस्तकवत्सकाः । सारिवादिहकटुकाः कैरालं त्रिफला वचा ॥ १० ॥

गुडूची मधुकं द्राक्षा दशमूलं सदीपनम् । रक्षोश्च पटलश्च गणः क्षीरविशोधनः ॥ १३ ॥

लाभतः क्रीधतस्तेषां कषायः स तु सेवितः । क्षीरे शोधयति क्षिप्रं त्रितय्याक्रमयुत ॥ १४ ॥

सहैद्रः कफसंसुष्टं सधृतः शेषयोर्भवेत् । केत्के श्लेष्मणः स्थानात् क्षीरे हि कफसंभवम् ॥ १५ ॥ (का० सं० सू० १९)

६. पिप्पलीपिप्पलीमूलं नागरं घनवालुकम् । कुसुम्बुरुणि मञ्जिष्ठां सह क्षीरिण कल्कयेत् ॥

पानं क्षीरविशुद्धयै कल्कभक्षणस्तन्यतरम् । मरिचं पिप्पलीमूलं क्षीरे क्षीरविशुद्धये ॥ (हो० सं० तु० स्था० ५/३/२, ३)

७. भार्गोदारुवचाः पिष्ट्वा पिबेत्साऽतिविषास्तथा ।

(पा० प्र० पूर्व० ४/२०, २१, २२)

by *kapha* and with *ghṛta* in cases of vitiation caused due to *vāta* and *pitta*. However, other authors contradict it on the logic that since *ghṛta* is similar in the qualities of *kapha* and milk also has natural predominance of properties of *kapha*, hence, use of *ghṛta* may be harmful.

xiv) *Pippalā, pippalāmūla, nāgara, ghana, vāluka, kustumburu* and *mañjiṣṭhā* should be pestled with milk and taken for purification of milk. After this, powdered *pippalā* and *pippalāmūla* should be taken with milk for increasing the quantity of milk.

xv) Pestled *bhāṅgū, dāru, vacā* and *ativisā* with water.

xvi) Decoction of *paṭola, nimba, asana, dāru, pālāṇ, mūrvā, guḍuḥ, kaṭurohinī* and *nāgara*.

वातादि दोषानुसार सत्य-दुष्टि की विशिष्ट चिकित्सा (Treatment of vitiation of milk according to predominance of vāta etc. doṣas)

(अ) वातिक सत्यदुष्टि-चिकित्सा (Treatment of milk vitiation caused by vāta)

(१) देवदार, सरल, कटुरोहिणी, चचा, कुश, पाठा, भाङ्गी, मागधिका, वृश्चिकाली, चित्रक, अजमोदा, शुण्ठी एवं मरिच का क्वाथ अथवा दसमूल का क्वाथ तीन रात तिलकर तपश्छात् वातव्याधि के लिए निदिष्ट धृतो^१ में से कोई या वातहर-द्रव्यों से साधित घृत को निर्दोष या स्वच्छ मटिका के अनुपान से दे^{१,३}।

अष्टाङ्गहृदय में अजमोदा के स्थान में दीपका का पाठ है तथा शुण्ठी का पाठ नहीं है अन्य औषधियाँ यही हैं^३। इस प्रकार स्निग्ध हो जाने पर मृदु विरेचन देकर बस्तिकर्म से चिकित्सा करें^{१,३}।

यौगन्तलाक में केवल दसमूल क्वाथ का तीन दिन पान करके वातहर सर्पि से स्नेहन के पश्चात् मृदु विरेचन का निर्देश है^३।

(२) वातजन अभ्यङ्ग, स्वेद, उपदेह एवं मर्दन का प्रयोग करें^{१,३}।

(३) सरल, रास्ता, अजमोदा तथा देवदार का चूर्ण घृत के साथ बालक को चटावें अथवा इन्हीं औषधियों से साधित घृत शर्करा के साथ चटावें^{१,३}।

(४) सर्वप्रथम धात्री को स्नेहन एवं स्वेदन कराकर नीलिका अथवा त्रिवृत् चूर्ण से युक्त घृत का पान कराएं। तत्पश्चात् सुसंस्कृत लघु एवं तिनाय घृष में दाडिम तथा सैन्धव मिला कर मृदु ओदन भोजन के लिए दें। उसे निवात स्थान में सोना

१. तत्र वातदुष्टितो सत्ये देवदारसलकटुरोहिणीचचकुशपाठाभाङ्गीमागधिकावृश्चिकालीचित्रकअजमोदशुण्ठीमरीचानां क्वाथं दश-मूलक्वाथं वा त्रिरात्रं पाययित्वा वातव्याधिविहितानां सर्पिषामन्यतमं निगदमटिकापुनः दद्यात्वातहरद्रव्यसिद्धं वा। ततः तिनायां मृदु विरेच्य बस्तिकर्मणोपचरेत्। वातनैश्चाभ्यङ्गस्वेदोपदेहोन्मदीनैः। सरलान्नाजमोदादेवदारचूर्णं सर्पिषा बालमवलहेयेत्। एतद्विधैरेव च विपक्वं सशर्करं सर्पिः॥ (अ० सं० उ० २८/११)

२. तत्र बालान्ते सत्ये दशमूलीं ग्रहं पिबेत्॥ १॥

अथवाऽपिचचापाठाकटुककुशदीपकम्। सप्तर्षीदारसलकटुवृश्चिकालीकणोपम्॥ १०॥
ततः पिबेदन्त्यनं वातव्याधिरं घृतम्। अमु चोच्छसुगमेवं तिनायां मृदु विरेचयेत्॥ ११॥
बस्तिकर्म ततः कुप्यस्वेदादींश्चानिलापहरं। रास्ताजमोदासलदेवदारसोऽन्वितम्॥ १२॥
बालो लिङ्गाद् घृतं तैवा विपक्वं सतिलोपलम्॥ १३॥ (अ० ह० उ० २९ से १३)

३. तत्र बालान्ते सत्ये दशमूलीं ग्रहं पिबेत्। वातव्याधिरं सर्पिः पीत्वा मृदु विरेचयेत्॥ (यो० १० श्लो० वि०)

एवं बैठना चाहिए। व्यायाम, अजीर्ण एवं मैथुन का परित्याग करें^१।

(५) सत्य-शोधन के लिए विदतिरास्या, एरण्ड, बृहती, गोक्षुरक, पुनर्नवा एवं पुरिषपणी अथवा द्विपञ्चमूल क्वाथ का पान करावें^१।

(६) रास्ता, सुगन्धा तथा नाकुली के कल्क का स्नानों में लेप करें^१।

(७) अजान्था, अवलज्जक, बृहती एवं कण्टकारिका अथवा शलाह, मधुक, अजान्था, करमरी, बृहती, कण्टकारिका, बला, पीलु एवं गुडवी के कल्क अथवा भद्रमुस्ता, त्पा एवं अगर के कल्क अथवा पुषप सर्पि एवं तिलकक से स्नान का प्रदेह करें^१।

(८) उरुपू, पलाश, पाटलि एवं रास्ता के क्वाथ अथवा सुखेष्ण दुग्ध से परिषेक करें^१।

i) Decoction of *devadāru, sarala, kaṭurohinī, vacā, kuśīha, pālāṇ, bhāṅgū, māgadhikā* or *daśamūla* should be given for three nights. After this, any *ghṛta* described for the treatment of *vātavādhī* or else the *ghṛta* prepared with the drugs capable of suppressing the *vāta*, followed by pure wine as after-drink should be given. Once the woman is oiled with the use of this *ghṛta*, mild laxatives followed by *eṣumā* should be used.

ii) Inunction, anointment, and massage with the oil and sudation with decoction prepared with the drugs capable of suppressing *vāta* should be given.

iii) The child should be made to lick either powdered *sarala, rāsna, ajamodā* and *devadāru* with *ghṛta* or *ghṛta* prepared with these drugs and mixed with sugar.

iv) After giving oleation and sudation to the wet-nurse she should be given powdered *milkā* or *trivṛt* with *ghṛta*. Then with well prepared, ligth, unctuous soup mixed with *dadīma* and rock-salt the soft-cooked rice should be given for eating. She should sit and sleep in a place not having direct entry of air. Exercise, indigestion and coitus should be given up by her.

v) To purify milk, decoction of *vidāriṅgandhā, eranda, bṛhatī, gokṣuraka, punarnavā* and *prśniparī* or both *pañcamūlas* be given.

vi) Paste of *rāsna, sugandhā*, and *nākulī* should be applied over breasts.

vii) Breasts be anointed/irrigated with paste/decoction of *ajugandhā, avalguṇā, bṛhatī* and *kanṭakārikā*, or *śatābhā, madhuka, ajugandhā, kāmara, bṛhatī, kanṭakārikā, bala, pīlu*, and *guḍuḥ* or *bhadravamsā, iwak* and *agaru* or old *ghṛta* with paste of *tila*.

viii) Irrigation with decoction of *urupūga, palāśa, pālāṇ* and *rāsna* or luke warm milk should be given.

१. तत्रादितश्चैव धात्री स्नेहाभ्यङ्गस्वेदोपपक्वां नीलिकाचूर्णयुतं सर्पिः पापयेत्, त्रिवृच्चूर्णितं वा। ततः संसर्गोपपादितालघुनिधैर्मूषैर्बालिन्सैन्धवयुतैर्दुग्धोदत्तमश्रयातिवातशयनसमना। व्यायामजीर्णमैथुनं च नानुचरेत्। विदतिरास्यैरण्डबृहतीगोक्षुरकपुनर्नवापुष्पव इति कषायमेनां पापयेत् सत्यशोधनाय, द्विपञ्चमूलकषायं वा। रास्ता सुगन्धा नाकुलीति कल्कः स्नानाय, तथाऽजान्थाऽवलज्जकबृहतीकण्टकारिकायुतः प्रदेहः। शलाहमधुकजान्थाकरमर्बृहतीकण्टकारिकाबलापीलुगुडवीकल्को वा भद्रमुस्ताल(ग)परकल्को वा पुषपसर्पिस्तिलकल्को वेति। अथोपपूषपलाशपाटलितानाक्वाथः परिषेकः, पयसा वा सुखेष्णेन वेति। (का० सं० छि १५/१५)

(आ) पित्तज सन्वदुष्टि-चिकित्सा (Treatment of vitiation of milk due to pitta)

(१) धात्री को स्नेह का अथवा कठोर चमन तथा विरेचन कराए। दोषों के निर्हरण के लिए निम्नोदक में पिप्पली-कल्क मिलकर अथवा पिप्पली एवं लवण के द्वारा चमन करावे; धात्री के बलानुसार उसे मृद्वीका, इक्षुस तथा अभया अथवा मृद्वीका के साथ अमलक को मिश्रित कर अथवा आरवधकलमञ्जा-कषाय से युक्त क्षीर से विरेचन करावें।^१ पित्तज विरेचन दें।^{२,३} तत्पश्चात् संसर्जन क्रम द्वारा कृताकृत विधान से यवागू अथवा यूष दें एवं निम्न कषाय में से कोई भी धात्री को स्तन्य शोषनार्थ पीने को दें।

- (अ) कारपरी, मधुक, परूषक एवं शीतलपर्क का सुशीतल शर्करा एवं मधु मिश्रित कषाय।^१
- (आ) परम्या, सारिवा, अमृता, मधुक एवं मृद्वीका का शर्करा मिश्रित कषाय।^१
- (२) निम्न कषाय धात्री एवं बालक को पिलावें।
- (अ) अमृता, पटोलपर्क, सारिवा, शलावरी, निम्ब एवं चन्दन का कषाय।^{२,३}
- (आ) त्रिफला, भूनिम्ब, कटुका एवं मुस्ता का कषाय।^३
- (इ) जीवक, ऋषभक, काकोलीद्वय, मधुक, कटुफल एवं कर्कटशृङ्गो का कषाय।^३
- (ई) पटोलादि^३ अथवा पञ्चकादि गण^२ का कषाय मधु के साथ।^३
- (उ) शारिवादि^३ अथवा न्यग्रोधादि गण की औषधियों का कषाय।^३
- (ऊ) अमृता, अभीर, पटोल, निम्ब एवं चन्दन का कषाय शर्करा से।^४
- (३) उपर्युक्त अ से उ में वर्णित द्रव्यों से सिद्ध घृत दें।^{३,३}
- (४) शीतल अथवा, प्रदेह, सेक^३ अथवा अथवा तथा आलेप^३ आदि का प्रयोग करें।^{३,३}
- (५) निम्नाङ्कित में से किसी एक कल्क का स्तनों में लेप करें—
अ) प्रपौण्डरीक, सारिवा, उशीर एवं चन्दन का कल्क।^१
आ) मधुक, क्षीरशुक्ला, चन्दन, रसाञ्जन एवं तुङ्ग का कल्क।^१
(३) यष्टीमधुक एवं चन्दन का कल्क।^१

१. धात्री स्नेहोपश्लेषपथान् चमनविरेचनेनोपकरोत्, निम्नोदकपिप्पलीकल्केन वाचमेत् पिप्पलीलवणयुक्तेन वा दोषनिर्हरणार्थं, मृद्वीकेशुसामवादिभिर्विरेचयेन्मृद्वीकामलकसंयोगेन वा आरवधफलमञ्जकषायसंयुक्तेन वा क्षीरेणैति यथाबलं चोक्ष्य। संसर्गा कारोद्यवावा यूपकृताकृतविधानेन वा। कारपरीमधुकपरूषकशीतलपर्क इति कृत्वा सुशीतं शर्करामधुलिखितं कषायं पायमे स्तन्यशोषनार्थं, परम्यासारिवामृतामधुकमृद्वीकानां कषायं शर्करायुतं चेति। प्रपौण्डरीकसारिवोशीरचन्दनकल्कः स्तनालेपः, मधुकक्षीरशुक्लाचन्दनरसाञ्जनतुङ्गयुतः प्रदेहः, यष्टीमधुकचन्दनकल्को वा, मधुकचन्दनभद्रमुस्तामण्डिरसाञ्जनकल्को वा, रसाञ्जनसारिवामधुकचन्दनोशीरकल्को वा, ककुभोदुम्बराश्वत्थवटनमूलशालूकवज्जुलकल्को वा घृतयुतः, विषण्णालपञ्चकमण्डिषाद्यारसाञ्जनकल्को चेति (का० सं० वि० १५/१६)

२. पित्तो मृतापटोलपश्याशलावतीनिम्बचन्दनकषायं धात्रीं बालश पिबेत्। त्रिफलाभूनिम्बकटुकामुस्तकषायं वा। जीवकपरूष-कटुिकाकोलीमधुककटुफलकटुशृङ्गिकषायं वा। सक्षौद्रं पटोलादि पञ्चकादि वा। शारिवादि न्यग्रोधादि वा। एषैरेव च द्रव्यैः सर्वाणि पित्तघ्नी च विरेचनानि शीतांशपाङ्कजप्रदेहसेकान् कुर्यात् ॥ (अ० सं० उ० २/१३)

३. पित्तदुष्टेऽग्राभीरपटोलीनिम्बचन्दनम् ॥ १३॥
धात्री कुमाश्व पिबेत् क्वाथयित्वा ससारिवम्। अथवा त्रिफलामुस्ताभूनिम्बकटुगोहिणीः ॥ १४॥
सारिवादि पटोलादि पञ्चकादि तथा गणम्। घृतात्योषिष सिद्धानि पित्तघ्नं च विरेचनम् ॥ १५॥
शीतांशपाङ्कजलेषदीन् युज्यात्॥ (अ० ह० उ० २/१३ से १६)

४. पित्तदुष्टेऽमृताभीरपटोलं निम्बचन्दनम्। धात्री कुमाश्व पिबेत्क्वाथयित्वा सशर्करम् ॥ (यो० १० क्षौलो० वि०)

स्तन्य एवं धात्री प्रकरण

- (ई) मधुक, चन्दन, भरमुस्ता, मण्डिषा एवं रसाञ्जन का कल्क।^१
- (उ) रसाञ्जन, सारिवा, मधुक, चन्दन, एवं उशीर का कल्क।^१
- (ऊ) ककुभ, उदुम्बर, अक्षय, वट, नलमूल, शालूक एवं वज्जुल के कल्क को घृत में मिला करे।^१
- (ए) विश, मृणाल, पञ्चक, मण्डिषा, पत्र एवं रसाञ्जन का कल्क।^१

i) After giving massage to the wet-nurse with oleaginous substances, she should be given emetics and purgatives. For expulsion of *dosas*, decoction of *nimba* with paste of *pippli*, or *pippli* with salt should be given for emesis, and looking into her strength of *mūdvikā*, sugarcane-juice and *abhyā*, or *mūdvikā* mixed with *āmalaka*, or decoction of pulp of fruit of *aragvadha* mixed with milk should be given for purgation. Purgatives capable of suppressing the *pitta* should be given. Afterwards medicated or mixed with *ghrita* and non-medicated or without adding *ghrita* the *yavagu* or *yūṣa* should be given in serial order, and then any one of the following decoction should be given to the wet-nurse for purification of milk.

- a) Well cooled decoction of *kāsmārī*, *madhuka*, *parīṣaka* and *śītapāt* mixed with sugar and honey.
- b) Decoction of *payasā*, *sārvā*, *amrā*, *madhūka* and *mūdvikā* mixed with sugar.
- ii) Decoctions prepared with following drugs should be given to the child and wet-nurse/mother both—

- a) *Amrā*, leaves of *patola*, *sārvā*, *śātāvarī*, *nimba* and *candana*.
- b) *Triphalā*, *bhūminba*, *kaiṣikā* and *muśā*.
- c) *Jivaka*, *ṛṣabhaka*, both *kākolis*, *madhuka*, *kaiṣikā* and *karkatāśīngī*.
- d) *Patolālī* or *padmākādi* group of drugs mixed with honey.
- e) *Sārvādi* or *nyagrōdhālī* group of drugs.
- f) *Amrā*, *abhinu*, *patola*, *nimba* and *candana* mixed with sugar.
- iii) *Ghrita* prepared with the drugs mentioned above under 'a' to 'e' should be given.
- iv) Cold inunctions, poultice, pourings or bathings and anointments should be prescribed.

v) Any one of the following be anointed over breasts.

- a) Paste of *prapaṇḍarīka*, *sārvā*, *uśīra* and *candana*.
- b) Paste of *madhuka*, *kṣīrasūkā*, *candana*, *rasātāyāna* and *tungā*.
- c) Paste of *yaśīmadhuka* and *candana*.
- d) Paste of *madhuka*, *candana*, *bhadrāmuśā*, *mañjīṣṭhā* and *rasātāyāna*.
- e) Paste of *rasātāyāna*, *sārvā*, *madhuka*, *candana* and *uśīra*.
- f) Paste of *kakubha*, *udumbara*, *aśwathā*, *vaiṭā*, root of *nala*, *śālūka* and *vañjīla* mixed with *ghrita*.

नोट—सन्दर्भ पूर्व पृष्ठ संख्या ७०२ में दे दिए गए हैं।

g) Paste of *viśā, mṛgāśā, padmāka, māṇḍiṣṭhā, padma* and *rasāyana*.

(इ) कफजन्य सन्त्य दुष्टि-चिकित्सा (Treatment of vitiation of milk due to kapha)

(१) सैन्धव एवं पिप्पली^१ अथवा सैन्धव एवं यष्ट्याह^{२,३} से युक्त घृत बालक को पीने को दें ।

(२) सैन्धव एवं मधुक^४ अथवा सैन्धव एवं पिप्पली^१ के साथ मदनपुष को पीसकर मधु मिलाकर^{१,३} अथवा केवल मदनपुष का^१ (धत्री के) स्तनों एवं बच्चे के ओठों पर लेप करें, इस योग से बच्चे को सुखपूर्वक वमन हो जाता है ।

(३) धात्री को तीव्र वायक औषधियों से वमन करावें^{१,३}, तत्पश्चात् ससर्जन-क्रम करके पञ्चमूल (वृहत्पञ्चमूल), वन, वचा एवं अतिविषा^१ अथवा मुस्तादि गण की औषधियों^२ अथवा निम्न द्रव्यों में से किसी एक का क्वाथ पान करावें ।

(अ) तार, सुतरा, सुरेन्द्रयव, पृथ्वीका तथा वृक्षिकाली^१ अथवा वृक्षिकाली के अतिरिक्त अन्य द्रव्य^{१,३} ।

(आ) अतिविषा, मुस्ता, षड्यन्था एवं पञ्चकोल का क्वाथ^१ ।

(इ) आरावधादि अथवा मुस्तादिगण की औषधियों का क्वाथ^१ ।

(४) धात्री का पूर्ववर्णीत विधि से उपचार करके अर्थात् स्नेहाभ्यङ्ग आदि देकर, उसे निम्बकाषाय एवं मदनफल, से सिद्ध तथा पयसि मात्रा में लवण से युक्त अथवा मदनफल, तिलगिष्ठ एवं ताड़ुल से सिद्ध यवाणु का वमन के विधान से पान करावें; अथवा लवण से युक्त द्रव्यों से सुखपूर्वक स्नेहन हो जाने पर, स्नेहा के उद्धरण के लिए उष्णोदक में पिप्पली मिश्रित कर पान करा वमन करावें, वमन काने के पश्चात् शिरोविरेचन करावें, तत्पश्चात् मृदु, सतीन, वेत्राय, पटोल, निम्ब एवं मुस्ताक में से किसी एक के यूष के साथ मृदु ओदन भोजन के लिए दें^४ ।

५) कुटजफल, मुस्ता, त्रियङ्गु, शार्ङ्गिष्ठा, पाठा, लोष, गूडची एवं मूर्वा में से यथोलब्ध द्रव्यों का एक अक्ष चूर्ण अथवा पाठा एवं गूडचरे का कल्क अथवा कुटजफल एवं पाठा का कल्क सुखोष्ण जल के अनुपात से पीने को दें, अथवा किरातलिकक एवं मुस्ता का चूर्ण मधु से लेहन करें^४ ।

(६) भद्रमुस्ता, अरिष्ट, पटोल, मूर्वा, दातहरीदा, त्रिफला एवं सप्तपर्णत्वक् के क्वाथ को सन्धान कर मधु के साथ पाक के रूप में प्रयोग करें^४ ।

(७) मुस्ताक एवं मालतीपत्र के कल्क का स्तनों में लेप करें^४ ।

(८) त्रिवृत्, त्रिफला एवं उष्ण जल में लवण मिला कर प्रयोग कर (विरेचन देकर) यूष का आहार विधि से सेवन करें^४ ।

(९) रक्ष एवं उष्ण नस्य, धूम, गाडूष, प्रदेह एवं परिक्षेक का प्रयोग करें तथा अतिरुद्ध अन-पान दें^४ ।

i) child should be given *ghṛta* either mixed with rock salt and *pipplā* or rock salt and *yasṭyāhwa*

ii) Rock salt and flowers of *madana* should be pestled either with *pipplā* or *madhuka* or else only flowers of *madana* should be pestled and applied over the teats of the wet-nurse and lips of the child. These applications induce pleasurable emesis to the child.

iii) Wet-nurse should be given strong emetics. After this emesis and *sansarjanakrama* (gradually increasing diet), decoction of *vr̥ṣṭapāṇcamūla*, *ghana vacā* and *ativisā* or else *mustādi* group of drugs or any one out of following should be given—

a) Decoction of *lagara, suradāru, surendrayava, pṛthvīkā* with or without *vr̥ṣṭikālā*.

नोट—कफजन्य सन्त्यदुष्टि की चिकित्सा के सन्दर्भ पृष्ठ ७०५ में देंगे ।

b) Decoction of *ativisā, mustā, śaḍgranthā* and *pañcākola*.

c) Decoction of *āraṇvadhādi* or *mustādi* group of drugs.

iv) After treating wet-nurse with the method described earlier (unctuous massage), she should be given *yavāgū* either made with decoction of *nimba*, medicated with fruit of *madana* and mixed with good quality of salt or made with fruit of *madana*, paste of *nīla* and *laṇḍāla* (pieces of rice), with the procedure of emesis; or else after pleasurable oleation given with articles mixed with salt, emesis should be induced with hot water mixed with *pipplā* for extraction of *śleṣmā*; after emesis, the head-evacuation should be given, then soft cooked rice with soup of any one out of *mudga, sāṇa, vetrāgra, paṭola, nimba* and *mustaka* be given in diet.

v) One *akṣa* powder of available drugs out of fruit of *kūṣṭha, mustā, pṛyangu, śāṅgīṣṭhā, pāṭhā, lodhra, guḍāci* and *mūrvā* or paste of *pāṭhā* and *śṛṅgabera* or paste of fruit of *kūṣṭha* and *pāṭhā* should be given using luke-warm water as after drink, or powder of *kīrātāika* and *mustā* with honey be given for licking.

vi) After fermenting decoction of *bhadramustā, ariṣṭa, paṭola, mūrvā, dāruharidra, triphalā* and stem-bark of *saptarṇa* the honey should be mixed in it and should be used as electuary.

vii) paste of *mustaka* and leaves of *mālāṭī* be anointed over breasts.

viii) After using (for purgation) *trivṛt* and *triphalā* with hot water mixed with salt, the soup should be given with the method of diet.

१. कफे तु सैन्धवपिप्पलीयुक्तं सपिर्बलं पाययेत् । सैन्धवमधुकसंयुतं वा मदनपुष्पकलेन च सक्षौद्रेण स्ननं बालस्य चोष्णमालिमेत् । तेन सुखं वमति । धात्री तु तीक्ष्णैर्बालमेत् । ततः कूलसंसर्जनं पञ्चलवचनचित्तिविक्षाद्यं पाययेत् । तारसुरदारसुरेन्द्रयवयुष्कीकावृक्षिकालीक्षाद्यं वा । आरावधादि मुस्तादि वा । रूक्षोष्णांश्च नस्ययुग्माण्डूषप्रदेहेपरिक्षेकान् शीलयेत् । अतिरुद्धं चात्रपानं योजयेत् ॥ (अ० सं० उ० २/१५)

२.स्नेहामातके पुनः । यष्ट्याहसैन्धवयुतं कुमार् पाययेद् घृतम् ॥ १६ ॥
सिन्धुलपिप्पलीपिष्टा पिष्टैः क्षौद्रयुतैश्च । यत्पुष्पैः स्तनौ तिम्रोच्छिद्योश्च दशनच्छदौ ॥ १७ ॥

सुखमेवं वमेद्वातः तीक्ष्णैर्धात्री तु वामयेत् । अथाऽचरितसंसर्गा मुस्तादिं क्वथितं पिबेत् ॥ १८ ॥
तद्वतारपृष्ठीकासुरदारकलिकान् । अथवाऽतिविषां मुस्तषड्यन्थापञ्चकोलकम् ॥ १९ ॥ (अ० ह० उ० २/१६ से १९)

३. कफदुष्टे घृतं पेयं यष्टिसैन्धवसंयुतम् । यत्पुष्पैः स्तनौ तिम्रोच्छिद्योश्च दशनच्छदौ ॥
सुखमेव वमेद्वातः कफकोपश्च शाम्यति ॥ (यो० २० क्षीरदो० चि०)

४. अथ धात्रीं पूर्वेण विधिनेपचारं निम्बकाषायमदनफलसिद्धां व्यक्तलवणां यवाणं पाययेदमदनफलतिलगिष्ठतण्डुलसिद्धां वा वमनिषधनेन सुखसलवर्णिगधयाः स्नेहोद्भूतार्णवं च पिप्पलपुष्पोदकं पीत्वा छर्दयेत्, कृतवमनायाः शिरोविचनं विदध्यान्मुरसतीनवेगमापटोलनिम्बमुस्तकानननमपरिहीतेन यूषेण मृदुमोदनं योजयेत् । कुटजफलमुस्ताप्रियङ्गुशार्ङ्गिष्ठा-पाठालोषाङ्गुवीमूर्त्तयक्ष्मनाणं यवालायं सुखोष्णोदकेनागुपिबेत्, पाठाप्रङ्गुबेकालकं वा, कुटजफलपाठाकलकं वा, किरातलिककमुस्ताचूर्णं वा मधुन लिहेत् । भद्रमुस्तारिष्टपटोलमूर्त्तारहरीदिगिराजसप्तपर्णचित्तिरेवैः कषायमासुतं मधुना पाकव्यपदेशात्पाययेत्, मुस्तकमालतीपत्रकलेन स्नानवालेपयेत् । अथ विरेचनं त्रिवृत्त्रिफलीष्णोदकवचनसंयुक्तमुपयोष्य यूषक्षारविधिः । (का० सं० चि० १५/१७)

ix) *Rukṣa* (dry) and hot inhalations, fumiigation, retention in mouth, poultice and bathings should be given. Congenital catables and drinkables should also be given.

(ई) द्रवज्वर सत्यदुग्धि-चिकित्सा (*Treatment of milk vitiation caused by two dosas or dwandwaja*)

सत्य को दूषित करने वाले दोनों दोषों को शमन चिकित्सा करनी चाहिए^१।

Treatment capable of pacifying both the dosas responsible for vitiation of milk should be prescribed.

(उ) सान्निपातिक सत्यदुग्धि-चिकित्सा (*Treatment of milk vitiated by all the three dosas or sannipātika*)

(१) सर्वप्रथम धात्री एवं बालक को शीघ्र ही चमन करावे^{२,३}। तत्पश्चात् संसर्जनक्रम करके, मुस्ता, पाठा, अतिविषा, कुष्ठ एवं कटुको का क्वाथ^३ पीने के लिए दें।

वचादि या हरिद्रादि गण का क्वाथ^{३,४} या मद्य आदि^५ अथवा निम्न द्वाथों में से कोई एक दें।

- (अ) रास्ता, अजमोदा, प्रियङ्गु, भद्रदार का क्वाथ^१।
- (आ) पाठा, तेजोवती, पुनर्वा, वृश्चिकाली का द्वाथ^२।
- (इ) भूमिम्ब, अमृता, कूटज-फल एवं शारिवा का द्वाथ^३।
- (ई) पाठादि महाक्वाथ^४।
- (उ) जम्बू, आम, तिन्दुक एवं कपित्थ के पत्रों का द्वाथ^५।
- (ऊ) बेल को तोड़कर उसका द्वाथ^६।
- (ए) मादी, पाठा, तिकि घन एवं आमय (कुष्ठ) का द्वाथ^७।
- (ऐ) पाठा, मूला, भूमिम्ब, दारु, शुण्ठी, कलिङ्गक, सारिवा, घन तथा तिका का द्वाथ^८।
- (२) अनुबन्ध होने पर (दोषों या अन्य उपद्रव स्वरूप उत्पन्न व्याधियों की) दोषानुसार एवं कालानुसार चिकित्सा करें^{३,४}।

i) First of all emesis should be induced immediately to the child and wet-nurse both. Now after doing proper *samsarjana-krama* (use of regulated diet in gradual manner i. e. tisanes or soups—scum of boiled rice—rice gruel then oleo etc.), decoction of either *mūstā, pāṭhā, aṭivīṣā, kuṣṭhā* and *kāṣṭhī* or *vacādi* or *haridrādi* group of drugs or else only wine

१. इन्द्रदुग्ध द्विगोणम् विशेषयेत् ॥ (यो २० क्षीरदोषं चि०)

२. तत्र धात्री बालं च पूर्वमेवायु चामयेत्। विहितसंस्काराद्युक्तमुस्तापाठादिषुकुष्ठकटुकानां द्वाथं चानाय दद्यात्। रास्तानजमोदाप्रियङ्गुभद्रदराणां वा। पाठतेजोवतीपुनर्वावृश्चिकालीनां वा। भूमिम्बामृतकुटजफलशारिवाणां वा। वचाहरिद्रादिगणयोर्वा। पाठादिमहाक्वाथस्य वा। जम्बूव्रतितिन्दुककपित्थपत्राणां वा। द्रित्यपङ्क्तस्य वा। अनुबन्धे च यथाव्याधिं प्रतिकुर्वीत।

(अ० सं० उ० २/१८)

३. तत्रायु धात्रीं बालं च चमनेनोपपदयेत् ॥ २३ ॥

विहितानां च संस्कारां प्रतिकुर्वीत योजयेद्गणम्। निशादि वाडयत्वा माद्रीपाठादिकथनाभायम् ॥ २३ ॥

अनुबन्धे यथाव्याधिं प्रतिकुर्वीत कालचित् ॥ (अ० इ० उ० २/२३, २४ च २६)

४. पाठामूला च भूमिम्बदारुशुण्ठीकलिङ्गकाः। सारिवाघनतिकास्तत्र सत्यविशोधनम् ॥ (यो २० क्षीरदोषं चि०)

५. मद्यादीनां वा योजयेत् ॥ (अ० इ० उ० २/२४ की अरुण० टीका)

should be given. Alternatively, decoction prepared with any one out of following groups should be used.—

- a) *Rāsnā, ajamodā, priyaṅgu* and *bhadrādāra*.
- b) *Pāṭhā, tejovatī, punaravā* and *vṛścikālī*.
- c) *Bhūmimbā, amṛtā, kuṣṭhā-phala* and *śārivā*.
- d) *Pāṭhādi* group of drugs.

e) Leaves of *jambū, āmra, tindaḥka* and *kapittha*.

f) Pulp of *bilva*.

g) *Mādri, pāṭhā, tikā, ghana* and *amaya* (*kuṣṭhā*).

h) *Pāṭhā, mārvā, bhūmimbā, dāru, śuṇṭhī, kaliṅgaka, śārivā, ghana* and *tikā*.

ii) In the cases having association of other complications, the treatment should be done considering the dominance of *doṣa* and period of disease.

अष्टाङ्गसंग्रह वर्णित वर्णरसादि के अनुसार विशिष्ट चिकित्सा (*Treatment of vitiation of milk on the basis of specific taste etc. described by Vagbhata I*)

(अ) वात से दूषित सत्य की रसादि के अनुसार चिकित्सा (*Treatment of vitiation of milk on the basis of its rasa or taste etc. caused by vāta*)

तिकागुरसं सत्यं मुद्गमाष्यलाशाभ्यां काकोलीयुगलेन च शोषयेत्। प्रियङ्गुधातकीपुष्पपत्रकदेवदारुक्षौद्रैर्वा। कषायगुरसं हिङ्गुसैन्धवाद्युतेन। फेनिलं विच्छिन्नं प्लवमानं च विल्वानिमन्थयुतेन पयसा होविषा च। सूयपर्णीका-कोलीबृहत्पल्लवजुषकनैर्वा ॥ (अ० सं० उ० २/१२)

तिकागुरस सत्य को मुद्ग, माष्य, पलाश एवं काकोलीद्वय (के द्वाथ के प्रयोग) अथवा प्रियङ्गु, धातकीपुष्प, पद्मक, देवदारु एवं मधु (के प्रयोग) से शुद्ध करें।

कषायगुरस को हिङ्गु एवं सैन्धव से युक्त घृत के प्रयोग से शुद्ध करें।

फेनिल, विच्छिन्न एवं तैरे वाले दुग्ध को बिल्व एवं अग्निमन्थ से सिद्ध दुग्ध एवं घृत अथवा सूयपर्णी, काकोली, बृहती तथा अवलजफल के प्रयोग से शुद्ध करें।

The vitiated milk having *tikānūrasa* (bitter after-taste) should be purified by use of decoction of either *mūdgā, maṣṣā, palāśa* and both *kākolīs*, or else *priyaṅgu*, flowers of *dhātakī, padmaka* and *devadāru* mixed with honey.

Kaṣṭhānūrasa (astringent after-taste) should be purified by use of *ghṛta* mixed with *hingū* and rock salt.

In *phenilā* (frothy), *vicclina* (having irregular precipitate) and *plavamāna* (floating if put in water) etc. disorders, the milk and *ghṛta* medicated with *bilva* and *agnimāntha* or else decoction of *supparparī, kākoli, brhātī* and fruits of *avalguja* should be given.

(अ) सैत्तिक सत्यदुग्धि में रस एवं वर्णानुसार चिकित्सा (*Treatment of vitiation of milk on the basis of rasa or taste and colour caused by pitta*)

तामावभासं। तत् प्रियङ्गुमुस्ताशाबलोदरैः शोषयेत्। आस्तानुरसं। तत् द्रक्षमायुक्पयसाश्री-

पर्याप्तः । कटुकानुरसं.....। तत् काकोलीविदारोभ्यां मधुपर्णा च । भृशोष्णं तन्मन्दन्तेतलकमलैः ॥

(अ० सं० उ० २/१४)

ताम्रावभास स्तन्य को प्रियङ्गु, मुस्ता एवं शानरलोष (के क्वाथ के प्रयोग) से शुद्ध करें ।

अम्लानुरस में द्राक्षा, मधुक, पयस्या (क्षीरविदारी ?) तथा श्रीपर्णी (के क्वाथ) का प्रयोग करें ।

कटुकानुरस में काकोली, विदारी तथा मधुपर्णा (गुडूची या विकंकत) का प्रयोग करें ।

अतिउष्ण दुग्ध की चिकित्सा के लिए चन्दन, उत्तल एवं कमल का प्रयोग करें ।

For purifying the milk, having coppery colour, decoction of *priyangū*, *mustā* and *śābaralodhva* should be used.

Amlānurasa (sour after-taste) should be treated with decoction of *drākṣā*, *madhuka*, *payasyā* and *śrīparṇī*.

In *kāṇḍikānurasa* (pungent after-taste) *kākolī*, *vidārī* and *madhuparṇā* should be used.

In *ati usṇa* (excessively hot) milk *candana*, *wipala* and *kamala* should be prescribed. (इ) रसैषिक स्तन्यदुग्धि की रसादि के अनुसार चिकित्सा (Treatment of disorders of milk on the basis of rasa or taste caused by kapha)

लवणानुरसं। तत् पिचुमन्दपटोलीक्षीरवृक्षैः शोधयेत् । तन्मुत्। तत् पिप्पलीनागरचूर्णेन समधुतेन । गुरु.....। तत् पाठाव्योषकल्केन पञ्चकोलचूर्णेन वा क्षौद्रधूतावृतेन । दोषोपक्रमणीयं चेक्षेत ।

(अ० सं० उ० २/१६)

लवणानुरस स्तन्य का पिचुमन्द, पटोली और क्षीरवृक्षों (वट, अश्वथादि के क्वाथ) से शोधन करें ।

तन्मुत् स्तन्य में पिप्पली एवं नागर के चूर्ण को मधु एवं घृत के साथ प्रयोग करें ।

गुरु स्तन्य में पाठा एवं व्योष या पञ्चकोल के चूर्ण को अधिक मात्रा में मधु एवं घृत मिला कर दें ।

दूषित स्तन्य की चिकित्सा के लिए दोषोपक्रमणीय अध्याय में वर्णित उपाय भी करें ।

The vitiated milk having *lavānānurasa* (salty after-taste) should be purified by the use of decoction of *picumanda*, *patolī*, and *kṣīrāvṛkṣa* (latex yielding trees).

In *tanumat* (presence of thread like structures) disorder of milk, powdered *pippalī* and *nāgara* with honey and *ghṛta* should be used.

In *guru* (heavy) disorder of milk, powder of either *pāṭhā* and *vyoṣa* or *pañcakola* mixed with good quantity of honey and *ghṛta* should be prescribed.

For all disorders of milk, the measures prescribed to suppress that particular *dōṣa* should be used.

(ई) तनु एवं सान्द्र आदि स्तन्यदुग्धि की चिकित्सा (Treatment of liquid and thick etc. other disorders of milk)

इक्षुमूलकरोवार्ध्यावृष्टाहैस्तनु शुद्ध्यति । सान्द्रं तु क्षौद्रकाश्चमर्यगुडूचीतण्डुलान्मूषः ॥

भृतेर्वा सुसक्षेप्तसर्षपावृहतीद्वयैः । ग्रथितं पक्वकोशेरफलिनीश्वेतचन्दनैः ॥

(अ० सं० उ० २/३०)

तनु स्तन्य, इक्षुमूल, करोर एवं गन्धह्व के प्रयोग से शुद्ध हो जाता है ।

सान्द्र स्तन्य में मधु, काश्मरी तथा गुडूची को तण्डुलान्मु के साथ अथवा सुरसा, खेत सर्प तथा दोनों वृहती के क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए, सान्द्र अर्थात् घन स्तन्य घमन-साध्य व्याधि है^१ ।

ग्रथित स्तन्य-दुग्धि में पक्व, उशीर, फलिनी एवं खेत चन्दन (के क्वाथ) का प्रयोग करना चाहिए ।

The *lanu* (liquid) milk gets purified by use of root of *ikṣu*, *kaśērā* and *yadvāhvā*.

In *sāndra* (thick) disorder of milk, either powdered *kāśmārī* and *guḍūcī* with honey and rice-water or decoction of *surasā*, *śvēta sarśapa* and both the *phalīnī* should be used. Emesis is beneficial.

In *grathita* (coagulated or clotted) disorder of milk, decoction of *padmaka*, *uśīra*, *phalīnī* (*priyāṅgū*) and *śvēta candana* should be prescribed.

चरकसंहिता वर्णित अष्ट क्षीरदोष-चिकित्सा (Treatment of eight milk disorders described by Caraka)

(१) विरस स्तन्य की चिकित्सा (Treatment of virasa or tasteless or insipid milk)

आयन्तर प्रयुक्त औषधि (Oral medication)

पायवेक्षिरसक्षीरं द्राक्षामधुकसारिकाः ॥ २६३॥

श्लक्ष्णपिष्टां पयसां च समालोड्य सुखान्मुना ॥ २६४ ॥ (च० सं० चि० ३०)

विरस क्षीरदुग्धि में द्राक्षा, मधुक, सारिका तथा पयस्या को खूब महीन पीसकर सुखोष्ण जल में घोलकर पीने को दें ।

Finely powdered *drākṣā*, *madhuka*, *sārīvā* and *payasyā* mixed with luke-warm water should be given.

बाह्य प्रयोग (External application)

पञ्चकोलकुलतथैश्च पिष्टैरालेपयेत्स्तनौ । शुष्कौ प्रक्षाल्य निर्दुह्यतथा स्तन्यं विशुध्यति ॥

(च० सं० चि० ३०/२६४, २६५)

पञ्चकोल एवं कुलतथ को महीन पीसकर स्तनों पर लेप दें । इस लेप के सूख जाने पर उसे धोकर दूध को निकाल दें (स्तनों में भरे हुए दूध को निचोड़ दें), इस प्रकार दुग्ध शुद्ध हो जाता है ।

Finely pestled *pañcakola* and *kulathā* should be applied over breasts. When this paste gets dried up, it should be washed and then milk should be expressed out properly.

(२) फेनसङ्घात स्तन्यदुग्धि की चिकित्सा (Treatment of phenasāṅghāta or frothy milk)

आयन्तर प्रयुक्त औषधियाँ (Oral medicines)

फेनसङ्घातवत्क्षीरं यस्यास्तां पायवेत् सिन्धवम् ॥ २६५॥

पाठा नागरशाईशमूर्वाः पिष्ट्वा सुखान्मुना ॥ २६६ ॥

किराततिककं शुण्ठीं सामृतां क्वाथयोद्धिषक् ॥ २६७॥

ते क्वाथं पायवेद्वाजीं स्तन्यदोषनिर्वाहणम् ॥ २६८॥ (च० सं० चि० ३०)

१.क्षीरघनत्व घमनसाध्या इति । (का० सं० चि० ७/३)

जिस स्त्री का फेससङ्गत सट्टय दुग्ध हो गया हो उसे पाटा, नागर, झाँझ तथा मूर्वा को पीसकर सुखेष्ण जल के साथ पिलावे ।

अथवा किरातलिक, शुण्ठी एवं अमृत के क्वाथ को स्नान-दोष निवारणार्थ पीने को दें ।

The woman whose milk resembles like collection of froth or mixed with froth should be given paste of *pāṭhā*, *nāgara*, *jhāṅghā* and *mūrvā* with lukewarm water. Alternatively decoction of *kirātālikā*, *śuṇṭhī* and *amarā* can also be used.

बाह्य प्रयोग (External application)

अञ्जनं नागरं दारुं किल्वमूलं प्रियङ्गुवः ॥ २६६ ॥

स्तनयोः पूर्ववत् कार्यं लेपनं क्षीरशोधनम् ॥ २६७ ॥

स्तनौ चालेपयेत् षट्द्वयगोष्ठसमर्धे ॥ २६८ ॥ (च० सं० चि० ३०)

अञ्जन, नागर, दारु, किल्वमूल (त्वक्) तथा प्रियङ्गु (फल) का (महीन पीस कर) पहिले की भाँति (विस दधान्तरात वर्णित विधि से) स्तनों पर लेप दुग्ध-शोधक होता है ।

अथवा स्तनों पर यत्, गेहूँ तथा सरसों पीसकर लेप करना चाहिए ।

Nicely pestled *amṛga*, *nāgara*, *dāru*, root bark of *bliva* and fruit of *priyāṅgu* should be applied over breast. When this plaster gets dried up, it should be washed and milk squeezed out. Similarly pestled *yava* (barley), *godhūma* (wheat) and *sarṣapa* (mustard) can also be applied.

(३) रुक्ष स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (Treatment of *rūkṣa* or dry milk or milk having no fat)

आभ्यन्तर प्रयोग (Oral medicine)

षड्विरेकाश्रितोक्तैरौषधैः स्तन्यशोधनैः । रुक्षक्षीरा पिबेत्क्षीरं तैर्वा सिद्धं घृतं पिबेत् ॥

(च० सं० चि० ३०/२६९)

रुक्ष क्षीर वाली स्त्री, षड्विरेकाश्रितोक्त औषधाय में वर्णित स्तन्यशोधक औषधियों (पृष्ठ ६९७) से सिद्ध दुग्ध या घृत का पान करे ।

The woman having *rūkṣa* milk, should use milk or *ghṛta* treated with *pāṭhā*, etc. ten milk-purifying drugs described earlier.

बाह्य प्रयोग (External application)

पूर्ववत्जीवकाशै च पञ्चमूलं प्रलेपनम् । स्तनयोः संविधातव्यं सुखेष्णं स्तन्यशोधनम् ॥

(च० सं० चि० ३३०/२७०)

जीवक आदि जीवनीय वर्ग की (दस) औषधियों एवं पञ्चमूल के सुखेष्ण कल्क का पूर्ववर्णित विधि से लेप स्तन-शोधक होता है ।

Luke-warm paste of *jīvaka* etc. ten drugs of *jīvānyā* group and *pāñcamūla* should be applied, then washed when dried, followed by expression of milk.

(४) विषाणं स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (Treatment of *vīṣaṇa* or discoloured milk)

आभ्यन्तर प्रयोग (Oral medicine)

यष्टीमधुकुम्भद्वीकापयस्यासिन्धुवारिकाः । शीताब्जना पिबेत्कल्कं क्षीरवैवर्धनशानम् ॥

(च० सं० चि० ३०/२७१)

यष्टीमधुक, मुद्गीका, पयस्या, सिन्धुवारिका के कल्क का शीतल जल से पान, क्षीर के वैवर्धन दोष का नाशक है । इस व्याधि को महर्षि काश्यप ने विरेचन के योग्य माना है ।

Use of pestled *yastīmādhuka*, *mūḍgīkā*, *payasyā* and *sindhuvārikā* with cold water cures *vīṣaṇyā* disorder. Use of purgatives is beneficial.

बाह्य प्रयोग (External application)

द्राक्षामधुककल्केन स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् । प्रक्षाल्य वारिणां चैव निर्दुष्टान्तौ पुनः पुनः ॥

(च० सं० चि० ३०/२७२)

स्तनों पर द्राक्षा तथा मधुक के कल्क का लेप कर (उस कल्क के) सूख जाने पर (स्तनों को) फानी से धोकर, बार बार दूध निकालना चाहिए ।

Paste of *drākṣā* and *mādhuka* should be applied over breasts, when dried, should be washed and milk expressed out repeatedly.

(५) दौर्गन्ध्य स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (Treatment of *dauṛgandhya* or foul smell of milk)

आभ्यन्तर प्रयोग (Oral medicine)

विषाणिकाजशृङ्गशौ च त्रिफलं रजनीं वचापम् । पिबेच्छीताब्जना पिष्टा क्षीरदौर्गन्धनाशिनम् ॥

लिङ्गालाङ्गयमधवाचूर्णं संव्योषं माक्षिकलुप्तम् । क्षीरदौर्गन्धनाशार्थं धात्री पञ्चाशिनी तथा ॥

(च० सं० चि० ३०/२७३, २७४)

विषाणिका (आवर्तकी, कर्कटशृङ्गी या मेघशृङ्गी ?), अजशृङ्गी, त्रिफला, रजनी तथा वचा को शीतल जल के साथ पीसकर पान करना दुग्ध की दुर्गन्धता का नाश करता है ।

अथवा अभया तथा व्योष के चूर्ण को मधु के साथ क्षीर-दुर्गन्ध नाशार्थ प्रयोग करें । साथ ही धात्री पञ्च आहार का प्रयोग करें ।

Use of *vīṣaṇikā*, *ajāśṛṅgī*, *triphalā*, *rajantī* and *vacā* pestled with cold water cures bad smell of milk.

Powdered *abhaya* and *vyoṣa* with honey should also be used for the purpose. Alongwith these drugs, the wet nurse should use congenial diet.

बाह्य प्रयोग (External application)

सावित्रीशरीरमञ्जिष्ठारलेष्मातकुकुचन्दनैः । पद्माब्जचन्दनोशीः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् ॥

(च० सं० चि० ३०/२७५)

१.विषाणक्षीरा। (का० सं० चि० ७५)

सारिवा, उशीर, मण्डिष्ठा, श्लेष्मातक तथा कुचन्दन अथवा पत्र, अम्ल, चन्दन तथा उशीर (के कल्क) का धात्री के स्तनों पर लेप करें।

Paste of either *sarivā*, *uśīra*, *mañjiṣṭhā*, *śleṣmāṭaka* and *kucandana* or *patra*, *ambu*, *candana* and *uśīra* should be applied over breasts.

(६) अति स्निग्ध स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (*Treatment of atisniṅgha or over unctuous milk*)

स्निग्धक्षीरा दारुमुस्तपाठाः पिष्ट्वा सुखायुना । पीत्वा ससैश्वरा क्षिप्रं क्षीरशुद्धिमवाप्नुयात् ॥

(च० सं० चि० ३०/२७६)

अतिस्निग्ध क्षीर-दोष से दूषित धात्री को दारु, मुस्ता, पाठा को पीसकर सैश्वर नमक मिलाकर सुखोष्ण जल से मिलाने पर दुग्ध को शुद्धि हो जाती है।

Oral use of paste of *dāru*, *mustā*, *pāṭhā* and rock salt with luke warm water purifies the milk.

(७) पिच्छिल स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (*Treatment of picchila or slimy milk*)

आभ्यन्तर प्रयोग (*Oral medicine*)

पाययेत् पिच्छिलक्षीरां शाङ्गैष्टमभयं चवाम् । मुस्तनागरपाठाश्च पीताः स्तन्यविशोधनाः ॥

तक्रारिष्टं पिबेच्चामि यदुक्तं गुदजोपहम् ॥ (च० सं० चि० ३०/२७७, २७८)

पिच्छिल दोष से दूषित दुग्ध वाली धात्री के द्वारा शाङ्गैष्ट, अभया, चवा, मुस्ता, नागर तथा पाठा (के कल्क) को सुखाम्बु में मिलाकर) का पान स्तन्य-शोधक है।

गुद-व्याधियों (अर्थ) में वर्णित तक्रारिष्ट का भी पान करना चाहिए।

Use of pestled *śāngaiṣṭā*, *abhaya*, *vacā*, *mustā*, *nāgara* and *pāṭhā* mixed with luke-warm water purifies the milk of wet-nurse having *picchila* milk.

Use of *lakṣarīṣṭa* prescribed for *guda-vyādhi* (diseases of anus or piles) is also beneficial.

बाह्य प्रयोग (*External application*)

विदारीबिल्वमधुकैः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् । (च० सं० चि० ३०/२७८)

धात्री के स्तनों पर विदारीकन्द, बिल्व तथा मधुक (के कल्क) का लेप करना चाहिए।

Pestled *vidārīkanda*, *bilva* and *mādhuka* should be applied over breasts.

(८) गुरु स्तन्यदुष्टि की चिकित्सा (*Treatment of guru or heavy milk*)

आभ्यन्तर प्रयोग (*Oral medicine*)

त्रयमाणामृतानिष्यपटेलनिफलानुतम् । गुरुक्षीरा पिबेदाशु स्तन्यदोषविशुद्धये ॥

पिबेद्वा पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम् ॥ (च० सं० चि० ३०/२७९, २८०)

गुरु दोष से दूषित स्तन्य वाली धात्री स्तन्यदोष की शुद्धि के लिए त्रयमाण, अमृता, निम्ब, पटेल तथा निफला का क्वाथ पिए।

अथवा पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक एवं नागर का क्वाथ पिए।

महर्षि काश्यप ने इसे वन-साध्य व्याधि माना है^१।

The wet-nurse having *guru* (heavy) milk disorder, should use decoction of either *trāyamaṇā*, *amarā*, *nimba*, *pāṭola* and *triphalā* or else *pippalīmūla*, *cavya* *citraka* and *nāgara*. These preparations purify her milk. Emesis is also beneficial.

बाह्य प्रयोग (*External application*)

बलनागरशाङ्गैष्टामूवीभित्तयेत् स्तनौ ॥ पुरिषपणीपयस्याभ्यां स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत् ॥

(च० सं० चि० ३०/२८०, २८१)

बला, नागर, शाङ्गैष्ट तथा मूर्वा (के कल्क) का स्तनों पर लेप करें।

या पुरिषपणी एवं पयस्या का धात्री के स्तनों पर लेप करें।

Paste of either *balā*, *nāgara*, *śāngaiṣṭā* and *mūrvā* or else *puṣṭipāṇī* and *payasyā* should be applied over the breasts.

□

१.क्षीरगौरव.....वमनाख्याता इति । (का० सं० चि० ७/३)

सन्दर्भ ग्रन्थ

(Bibliography)

अंग्रेजी-हिन्दी-कोश : फ़ॉरे कार्मिल बुल्के, कैथोलिक प्रेस, रॉचो, १९६८ (प्रथम संस्करण)

An English-Hindi Dictionary : By Father C. Bulcke, Catholic Press, Ranchi, 1968; (1st ed.)

अमकोष (अमसिंह विरचित) : भगुनि दीक्षित कृत रामश्रमी (व्याख्यासुधा) टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९७० (प्रथम संस्करण)

Amarakosa (of Amarasimha) : With Rāmāśramī (Vyākhyāsudhā) commentary of Bhānuji Dīkṣita; Chaukhambha Sanskrit Series Office, Varanasi, 1970 (1st ed.)

अष्टाङ्गसंग्रह, (प्रथम भाग*) : अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका; निर्णयसागर मुद्रणालय, बनारस, १९५१, (प्रथम संस्करण)

वही : (द्वितीय भाग*) : अत्रिदेव विद्यालंकार कृत हिन्दी टीका; अत्रिदेव विद्यालंकार, बौसफाटक वाराणसी, १९६२, (प्रथम संस्करण)

वही : (प्रथम एवं द्वितीय भाग**); इन्दु व्याख्या सहित; रुद्रप्रसाश्व द्वारा त्रिचूर में प्रकाशित, १९१३ (प्रथम संस्करण)

वही : इन्दु व्याख्या सहित** महेश अनन्त आठवले, श्रीमद् आश्रय प्रकाशनम् 'नन्दनन्द', पुणे, १९८० (प्रथम संस्करण)

AṣṭāṅgaSaṅgraha (Part I*) : Hindi Comm. by Atrideva Gupta; Nirṇaya Sāgara Press, Bombay, 1951 (1st ed.)

Ibid : (Part II*) : Hindi comm. by Atrideva Vidyālakar; Atrideva Vidyālakar; Bansaphatakā, Varanasi, 1962 (1st ed.)

Ibid : (Part I & II**) : With Indu Commentary; Rudraparashava, Trichura, 1913 (1st ed.)

Ibid : With commentary by Indu**, Maheśa Ananta Āṭhāwale, Śrīmad Ātreya Prakāśanām 'Nandanandana' Pune, 1980 (1st ed.)

अष्टाङ्गहृदय* : लालचन्द्र वैद्य कृत हिन्दी टीका; मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६३ (प्रथम संस्करण) ।

वही** : अरुणदा कृत सर्वाङ्गसुन्दरा एवं हेमदि कृत आयुर्वेदसायन टीका; चौखम्भा ओरियन्टलिया, वाराणसी, १९८२ (सप्तम संस्करण)

Aṣṭāṅga Hṛdaya* : Hindi Comm. by Lal Chandra Vaidya, Motilal Benarasi Dass, Varanasi, 1963 (1st ed.)

Ibid** : With Sarwāṅgasundarā comm. of Arjunadatta and Āyurvedarāṣāyana comm. of Hemadri; Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1982 (VIIth ed.)

ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स (मुरोकर की) : जे. चस्सर मॉयर एवं पी. आर. म्येरस्कौग, बैङ्कीरे, रिण्डाल एवं कास्सेल लन्दन, १९७१ (अष्टम संस्करण)

Operative Obstetrics (Munro Ker's) : J. Chassar Moir and P. R. Myerscough; Baillière, Tindall and Cassell London, 1971 (VIIIth ed.)

आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स इन गायनिकॉलॉजी : नि. ग. जोशी, ज. ग. जोशी, शुभदा प्रकाशन १३९९, सदाशिव पेट. पूना, १९६५ (प्रथम संस्करण)

Āyurvedic Concepts in Gynaecology : By N. G. Joshi; J. G. Joshi, Shubhada Prakashan, 1399, Sadashiv Peth, Poona, 1965 (1st ed.)

काश्यप संहिता* : प्रो० प्रेमवती तिवारी कृत सम्पादन एवं ऑलभाषा अनुवाद, चौखम्भा विश्वभारती प्रकाशन वाराणसी, १९९६ (प्रथम संस्करण)

वही** : श्री सत्यपालविभगाचार्य कृत हिन्दी टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९५३, (प्रथम संस्करण)

KāśyapaSaṁhitā* : Edi. and translated by Prof P.V. Tewari, Chaukhambha Viswabhārati. Prakashan 1996, (1st ed.)-

Ibid** : Hindi comm. by Shri Satyapāla Bhiṣagūcārya; Chaukhambha Sanskrit series of- fice, Varanasi 1953, (1st ed.)

चक्र संहिता (चक्रपाणिदत्त कृत आयुर्वेदटीपिका टीका सहित) : पं० काशीनाथ शास्त्री कृत "विद्योतिनी" टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी,

प्रथम भाग, १९६९ (प्रथम संस्करण)

द्वितीय भाग, १९७० (प्रथम संस्करण)

Caraka Saṁhitā : With Āyurvedaṭīpikā comm. of Cakrapāṇidatta; 'Vidyotini' comm. by Pt. Kāśinātha Śāstri; Chaukhambha Sanskrit series office, Varanasi;

Part I 1969 (1st ed.)

Part II 1970 (1st ed.)

टेक्स्ट बुक ऑफ गायनिकॉलॉजी (श्री की) : जॉन हाकिंस एवं गॉर्डन बॉन द्वारा परिरचित; दि ईंग्लिश लैबरेज बुक सोसाइटी एवं चर्चिल लिमिंग स्टेन, लन्दन, १९७५ (नवम संस्करण)

Text Book of Gynaecology (Shaw's) : Revised by Jhon Howkins and Gordon Bourne; The English language book Society & Churchill Living Stone, London, 1975 (IXth ed.)

पाराशरस्मृति : श्री वासुदेव कृत हिन्दी टीका; चौखम्भा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९८३ (द्वितीय संस्करण)

Pārāśara Smṛti : Hindi Comm. by Śrī Vāsudeva, Chowkhambha Amarabharati Prakashan, Varanasi, 1983 (2nd ed.)

प्रत्यक्षशरीरम् : (महामहोपाध्याय गणनाथ सेन विरचित), प्रथम भाग:-कविराज यश. के. सेन, कल्पतरु पैलेस, कलकत्ता, १९४० (चतुर्थ संस्करण)

वही : द्वितीय भाग: कविराज चारुचन्द्र विशारद, कल्पतरु आयुर्वेदिक वर्क्स, ग्रे स्ट्रीट, कलकत्ता, १९२४ (प्रथम संस्करण)

Pratyakṣa Śarīram : By Gaṇanāṭha Sen, Part I—Kavirāja S. K. Sen, Kalpataru Palace, Calcutta, 1940 (IVth ed.)

Parts II—Kavirāja Cārucandra Viśārada, Kalpataru Ayurvedic works, Grey Street Calcutta. 1924 (1st ed.)

प्रिन्सिपल्स ऑफ गार्निनिकालीज : सर नार्मन जेफकोट : बटरवर्थ एण्ड को. (प्रकाशक) लिमि० लन्दन एवं वास्टर, १९७५ (चतुर्थ संस्करण)

Principles of Gynaecology : By Sir Norman Jelfcoat: Butterworth and Co. (Publishers) Ltd. London and Boston, 1975 (IVth ed.)

भाष्यकारा : श्री ब्रह्मशङ्कर मिश्र कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी;

प्रथम भाग १९६९ (प्रथम संस्करण);

द्वितीय भाग १९६४ (तृतीय संस्करण)

Bhāwāpṛakāśa : 'Vidyoti' Hindi comm. by Śrī Brahama Śaṅkara Miśra: Chaukhambha Sanskrit series office Varanasi;

Part I 1969 (Vth ed.)

Part II 1964 (IIIrd ed.)

भेलसंहिता : चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९५९ (प्रथम संस्करण)

BhelaSaṁhitā : Chaukhambha Vidyabhavana, Varanasi, 1959 (1st ed.)

माधवनिदानम् (पूर्वार्द्धम्) : श्रीविजयरक्षित श्रीकाण्डवत कृत 'मधुकोष व्याख्या' एवं सुदर्शन शास्त्री कृत 'यशोवती' टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, १९६६ (तृतीय संस्करण)

वही : (उत्तरार्द्धम्) : श्रीविजयरक्षित श्रीकाण्डवत कृत 'मधुकोष व्याख्या' एवं श्री दीनानाथ शर्मा कृत 'यशोवती' टीका; मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, दरियागाँव दिल्ली, १९५० (द्वितीय संस्करण)

MādhavaNīdānam Purvārdham) : With 'Madhukosa' comm. of Vijayarakṣita Śrīkaṇṭhādatta and 'Vidyoti' Hindi Comm. by Sudarshana Shastri: Chaukhambha Sanskrit series office, Varanasi, 1966 (IIIrd ed.)

Ibid (Uttarārdham) : With 'Madhukosa' comm. of Vijayarakṣita Śrīkaṇṭhādatta and 'Yaśowatī' Hindi comm. by Śrī Dīnānātha Sharma; Mehara chandra Lakshamana dasa, Dariya Ganja Delhi, 1950 (IInd ed.)

मैनुअल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स (हालैण्ड एवं ब्रिज को) : राबर्ट परसीवेल, इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी एण्ड बे० एण्ड ए० चर्चिल लिमि० लन्दन, १९६९ (त्रयोदश संस्करण)

Manual of Obstetrics (Holland and Brew's) : Robert Percival; The English language book Society and J. & A. Churchill Ltd. London, 1969 (XIIIth ed.)

मैनुअल ऑफ मिड्विफरी : हेनरी जेलेट एवं डेविड जी० मैण्डल-लिखित; बैल्लिरे टिण्डल एण्ड को०, लन्दन, १९११ (तृतीय संस्करण)

Manual of Midwifery : By Henry Jellett and David G. Mandli; Bailire Tindall and Co-London, 1921 (IIIrd ed.)

योगलताका : लक्ष्मीपति शास्त्री कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, १९५५ (प्रथम संस्करण)

Yogaratanākāra : 'Vidyoti' Hindi comm. by Lakshmiṇipati Shastri: Chaukhambha Sanskrit series office, Varanasi, 1955 (1st ed.)

वङ्गसेन संहिता : राजीवकुमार राय कृत हिन्दी टीका; प्राच्य प्रकाशन वाराणसी, १९८३ (प्रथम संस्करण)

Vaṅgaseṇa Saṁhitā : Hindi comm. by Rajiva Kumara Rai, Prachya Prakashan Varanasi, 1983 (1st ed.)

शार्ङ्गधर संहिता* : प्रयागराज शर्मा कृत हिन्दी टीका; चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, १९६६ (चतुर्थ संस्करण)

वही** : आडमल्ल कृत 'दीपिका' एवं काशीराम वैद्य कृत 'गूढार्थदीपिका' टीका; चौखम्भा ओरियन्टलिया, वाराणसी, १९८३ (तृतीय संस्करण)

Śaṅgadhara Saṁhitā* : Hindi comm. by Śrī Prayagadatta Sharma, Chaukhambha Sanskrit series office Varanasi, 1966 (IVth ed.)

Ibid** : With 'Dīpikā' comm. of Ādhamalla and 'Gūḍhārtha Dīpikā' comm. of Kāśīrāma Vaidya, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1983 (IIIrd ed.)

संस्कृत इंग्लिश डिक्शनेरि : सर मोनियर मोनियर-विलियम विरचित; मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, १९७० (प्रथम संस्करण)

Sanskrit English Dictionary : By Sir Monier Monier-Williams; Motilal Benarasi Das Delhi, 1970 (1st ed. Indian)

संस्कृत इंग्लिश डिक्शनेरि : वामन शिवराम आर्टे विरचित; मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९७३ (प्रथम संस्करण)

Sanskrit English Dictionary : by Vaman Shivram Apte; Motilal Benarasi Das, Delhi, 1973 (1st ed.)

सुश्रुत संहिता* : डल्हानाचार्य कृत निबन्धसंग्रह एवं निदानस्थान में गयदासचार्य कृत न्यायचन्द्रिका पञ्जिका टीका; चौखम्भा ओरियन्टलिया १९८० (चतुर्थ संस्करण-पुनर्मुद्रण)

वही** : डल्हानाचार्य कृत 'निबन्धसंग्रह' टीका; सी० के० सेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, पूर्वभाग** - तमकाण्ड १८५९ (प्रथम संस्करण)

पर भाग** - तमकाण्ड १८६० (प्रथम संस्करण)

वही** : चक्राणीवत कृत 'भानुमती व्याख्या'; श्यामसुन्दर शर्मा, एम० ए०, रीजिस्ट्रार अगाता विश्वविद्यालय एवं मन्त्री स्वामी लक्ष्मीराम निधि, १९३९ (प्रथम संस्करण)

वही** : श्री भास्कर गोविन्द घणेशकर कृत 'आयुर्वेद रहस्य दीपिका' टीका; जयकृष्णदास हरिदास गुप्त चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, १९५० (द्वितीय संस्करण)

वही** : अम्बिकादत्त शास्त्री कृत 'आयुर्वेद तत्त्वसन्दीपिका' व्याख्या; चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, भाग १ - १९६६ द्वितीय संस्करण

भाग २ - १९६८ द्वितीय संस्करण

Suśruta-Saṁhitā* : With Nibandha Saṅgraha comm. of Dalhanācārya and Nyāyacandrikā Pāñjikā comm. of Gayadaśācārya on Nīdāna Sthāna; Chaukhambha Orientalia, 1980 (IVth ed. reprint)

- Ibid : With 'Nibandha-Saṅgraha' comm. of Dallanācārya, C. K. Sen and Co. Ltd. Calcutta.,
Pūrva Bhāṣā** (Part I) Tamakābda 1859 (1st ed.) ;
Para Bhāṣā** (Part II) Tamakābda 1860 (1st ed.)
- Ibid** : With 'Bhāṇanāt' comm. of Cakrapāṇidatta; Shyamasundara Sharma, Registrar
Aguar University and Secretary Swami Lakshmi Rama Trust, 1939 (1st ed.)
- Ibid** : 'Āyurveda Rahasya Dipikā. Comm. by Shri B. G. Chanekara, Jaikrishnadasa.
Haridas Gupta, Chowkhambha Sanskrit series office, Varanasi, 1950 (1Ind ed.)
- Ibid** : 'Āyurveda Taṭva Saṃdipikā' comm. by Ambikadatta Shastri; Chaukhambha Sanskrit series office, Varanasi,
Part I - 1966 (1Ind ed.)
Part II - 1968 (1Ind ed.)
- हरितसंहिता* : रविवत्सानी कृत टीका सहित; गङ्गाविष्णु, गणपतकुम्भानी मुद्रणालय, बनारस, १८९३ (प्रथम संस्करण)
वही** : एलीराजन, इन्स्टीट्यूट डे फ्रॉमिस, इण्डोलानी, पाण्डुचेरी, १९७४ (प्रथम संस्करण)
HārītaSaṃhitā** : Hindi comm. by Ravidatta Shastri; Gangavishnu, Ganapatakrishnaji Press, Bombay, 1893 (1st ed.)
- Ibid** : Elirajan, Institute De Fransis Indology, Panducher, 1974 (1st ed.)

यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक में '***' चिह्नित पुस्तकों की विषयवस्तु का भी प्रयोग किया गया है, परन्तु सन्दर्भसंख्या '**' चिह्नित पुस्तकों से ही उद्धृत की गई है।

(Though subject matter of '***' marked books is also taken, however, in references, the verse numbers from books marked '**' only have been cited.)

परिशिष्ट - एक (Appendix - I) मान (Measures)

आयुर्वेदिक संहिताओं में तीन प्रकार के मानों का वर्णन है। पौलव मान (भार मान), द्रव्य मान (आयतन मान) एवं पाय्य मान (लम्बाई का मान)। सम्प्रति ग्रन्थ का सम्बन्ध केवल पौलव मान से है।

पौलव मान दो प्रकार का है, मापण एवं कालिङ्ग। यद्यपि मापण मान ही अधिक मान्य रहा है, परन्तु दार्शन्याधिक या मीटरी पद्धति से तुलनात्मक विवरण करने पर कालिङ्ग मान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि आजकल सामान्य रूप में १ माष (मासा) को १ ग्राम तथा १ कर्ष को १० ग्राम मान लेते हैं जो कालिङ्ग मान सदृश (१० माष = १ कर्ष) है। अतः मानात्मिका कालिङ्ग मान के ही आधार पर वर्णित है।

In *āyurvedika* classics three types of measures are described, i.e. *pautava māna* (measure of weight), *dravya māna* (measure of volume) and *pāyva māna* (measure of length). The present book is concerned only with *pautava māna*.

This *pautava māna* is of two types i.e. *māgadhā* and *kālīṅga*. Though earlier, *māgadhā* was more acceptable to *āyurvedika* world, however, in attempting to correlate these measures with today's prevalent measures of metric system, *kālīṅga māna* is convenient, because now a days generally one *māṣa* (*māṣā*) is taken as one gramme and one *tolā* or *karṣa* as ten grammes, which is in conformity with *kālīṅga māna* (ten *māṣa* = 1 *karṣa*). Thus, present table is given on the basis of *kālīṅga māna*.

संहिताओं में वर्णित मान	अधुना मान्य दार्शन्याधिक पद्धति का मान
(Measure described in <i>āyurvedika</i> classics)	(Presently acceptable measure of metric system)
गुञ्जा (<i>Gujjā</i>) =	१२५ मि० ग्रा० (125 mgm)
८ गुञ्जा =	१ माष = १ ग्राम
(8 <i>Gujjā</i>) =	1 <i>Māṣa</i> = 1 gram
४ माष =	१ शाण = ४ ग्राम
(4 <i>Māṣa</i>) =	1 <i>Ṣaṇa</i> = 4 grams
१० माष =	१ कर्ष = १० ग्राम
(10 <i>Māṣa</i>) =	1 <i>Karṣa</i> = 10 grams
२ कर्ष =	१ शुक्ति* = २० ग्राम
(2 <i>Karṣa</i>) =	1 <i>Śukti</i> * = 20 grams
२ शुक्ति* =	१ पल = ४० ग्राम
(2 <i>Śukti</i> * =	1 <i>Paḷa</i> = 40 grams)

२ पल	=	१ प्रमुत*	=	८० ग्राम
(2 Pala)	=	1 Prastha*	=	80 grams)
२ प्रमुत*	=	१ कुडव	=	१६० ग्राम
(2 Prastha*)	=	1 Kudava	=	160 grams)
२ कुडव	=	१ मानिका	=	३२० ग्राम
(2 Kudava)	=	1 Manika	=	320 grams)
२ मानिका	=	१ प्रस्थ	=	६४० ग्राम
(2 Manika)	=	1 Prastha	=	640 grams)
४ प्रस्थ	=	१ आढक	=	२.५६ कि० ग्राम
(4 Prastha)	=	1 Adhaka	=	2.56 K.gs)
४ आढक	=	१ द्रोण	=	१०.२४ कि० ग्राम
(4 Adhaka)	=	1 Drona	=	10.24 K.gs)
१०० पल	=	१ तुला	=	४ कि० ग्राम
(100 Pala)	=	1 Tula	=	4 K.gs)
मुष्टिक प्रमाण**		एक मुष्टी में आने योग्य द्रव्य की मात्रा		
(Mushika Pramanam **)		(Fistful quantity)		

* कालिङ्गमान में वर्णित न होकर मागधमान में वर्णित हैं ।

* (Not described in *kalinga māna* but described in *māgadhā māna*)

** इन मानों में वर्णित नहीं है परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में उद्धृत है ।

** (Not described in measures, but referred in the book)

परिशिष्ट-२ औषधि योग सूची

यद्यपि पुस्तक में यत्र-तत्र अनेकों द्रव्यों से निर्मित चूर्ण, कल्क, क्वाथ, घृत एवं तैल आदि कल्पनाओं का वर्णन है, परन्तु उन सभी का विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है । प्रस्तुत सूची में विशिष्ट नाम से वर्णित योगों के ही साथ एकौषधि या एक विशिष्ट औषधि वर्ग से साधित घृत, तैलादि का भी अकारादि क्रम से व्यवस्थान है ।

योग-नाम	पृष्ठ-संख्या	प्रयोग-विधि	विकल्प-व्याधि
अरिष्ट-			
अच्छ अरिष्ट	५७४	आभ्यन्तर	मक्कल शूल
अभयारिष्ट	३३७	आभ्यन्तर	गर्भपातोपशान्त वरित एवं उदर का शूल
"	४०९	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
तक्रारिष्ट	७१२	आभ्यन्तर	पिच्छिल स्तन्यदुष्टि
अवलेह-			
कल्याणकावलेह	२६९	आभ्यन्तर	गर्भणी-अतिसार
क्वाथ-			
देवदर्यादि क्वाथ	५६७	आभ्यन्तर	सूतिकारोग
हीबेरादि क्वाथ	२७०	आभ्यन्तर	गर्भणी-अतिसार
घृत-			
अमृतसर्पि	४२४	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
करञ्जाघ घृत	५७९	स्थानिक प्रयोग	रक्तविद्रधि
कल्याणक घृत	४०८	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
"	६०२	आभ्यन्तर	सूतिका का श्लेष्म ज्वर
"	६०५	आभ्यन्तर	सूतिका का साक्षिपातिक ज्वर
"	६६३	आभ्यन्तर	घात्री का अग्नि विकार
"	४०७	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
काकोल्यादि घृत	३६७	आभ्यन्तर	उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ
गुग्गुल्लादि घृत	५७९	परिषेवन	रक्तविद्रधि
जीवनीय घृत	४०८	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
तिक्त घृत	५८१	आभ्यन्तर	रक्तविद्रधि
"	५९९	आभ्यन्तर	सूतिका का पित्तज्वर
तिक्त सर्पि	५९९	आभ्यन्तर	सूतिका का पित्तज्वर
तिक्तपाघ घृत	५८१	आभ्यन्तर	रक्तविद्रधि
तिलक घृत	५८१	आभ्यन्तर	रक्तविद्रधि
त्रायमाण घृत	५८१	आभ्यन्तर	रक्तविद्रधि

योग-नाम	पृष्ठ-संख्या	प्रयोग-विधि	चिकित्स्य-व्याधि
त्रिफला घृत	६९३	आभ्यन्तर	स्तन्य-दुग्धि
दशमूल घृत	६०२	आभ्यन्तर	सूतिका का श्लेष्मज्वर
पञ्चगव्य घृत	४०८	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
" "	६०५	आभ्यन्तर	सूतिका का साक्षिपातिक ज्वर
पिप्पल्यादि घृत	४१३	उत्तरवर्त्ति	रक्तगुल्म
फल घृत	९३	आभ्यन्तर	संभोग के पूर्व
मङ्गल्यक घृत	६०५	आभ्यन्तर	सूतिका का साक्षिपातिक ज्वर
महाकल्याण घृत	९३	आभ्यन्तर	संभोग के पूर्व
" "	६०५	आभ्यन्तर	सूतिका का साक्षिपातिक ज्वर
महापैशुचिक घृत	३६७	आभ्यन्तर	उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ
वचा घृत	३६७	आभ्यन्तर	उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ
शतधौत घृत	३३९	अधोदर में लेप	परिहार्य गर्भश्लव
षट्पल घृत	४०८	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
" "	६६३	आभ्यन्तर	धानी का अनिधिकार
सहस्रधौत घृत	३३९	अधोदर में लेप	परिहार्य गर्भश्लव

वर्गाषधि साधित घृत-

अमृतौषध	४१४	आभ्यन्तर	रक्तगुल्म
गर्भस्थापन द्रव्य	२३९	आभ्यन्तर	गर्भस्थापन
चन्दनादि वर्ण	५९९	आभ्यन्तर	सूतिका का पित्तज्वर
जीवनीय गण	२३९	आभ्यन्तर	गर्भस्थापन
" "	३६७	आभ्यन्तर	उपशुष्क एवं उपविष्टक गर्भ
" "	४१४	पान, बस्ति	रक्तगुल्म
" "	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका को परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका को व्याधियाँ
" "	५७९	परिचर्चन	रक्तविद्विध
तिक्त द्रव्य	४१४	अनुवासन बस्ति	रक्तगुल्म
त्रिफला	६९३	आभ्यन्तर	स्तन्यदुग्धि
न्यग्रोधादि गण	५७९	स्थानिक प्रयोग	रक्तविद्विध
पटोलादि वर्ण	५९९	आभ्यन्तर	सूतिका का पित्तज्वर
भौतिक द्रव्य	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका को व्याधियाँ
मधुरौषध	९३	आभ्यन्तर	संभोग के पूर्व
" "	२२३	अनुवासन बस्ति	गर्भोपरिचर्या
" "	२५२	आभ्यन्तर	क्रिकिस

योग नाम	पृष्ठ-संख्या	प्रयोग-विधि	चिकित्स्य व्याधि
मधुरौषध	३६७	आभ्यन्तर	उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ
" "	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका को परिचर्या
" "	५५८	बाह्यप्रयोग	सूतिका को व्याधियाँ
वाजीकरण	६९४	आभ्यन्तर	स्तन्यदुग्धि
वातहर द्रव्य	३६७	आभ्यन्तर	उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ
" "	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका को परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका को व्याधियाँ
वृंहणीय	३६७	आभ्यन्तर	उपविष्टक एवं उपशुष्क गर्भ
" "	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका को परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका को व्याधियाँ

तैल-

अतिबला तैल	५३९, ५३८	बाह्य एवं आभ्यन्तर	मूढगर्भ
अनन्ता तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
आटी तैल	६६९	अभ्यङ्ग, पित्तु	धानी की व्याधियाँ
आदित्यपर्णी तैल	५३८	बाह्य एवं आभ्यन्तर	गर्भिणी को परिचर्या
कदम्बमाष तैल	२२४	अनुवासन बस्ति	गर्भिणी को परिचर्या
कापित्थ तैल	६६८	अभ्यङ्ग, पित्तु	धानी की व्याधियाँ
कुष्ठ तैल	६२१	सिञ्चन	शिशु को नाभि का
क्रौञ्च तैल	६६९	अभ्यङ्ग, पित्तु	धानी की व्याधियाँ
गुह्यो तैल	५३९, ५३८	बाह्य एवं आभ्यन्तर	मूढगर्भ
" "	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
क्रिकष्टक तैल	५३८	बाह्य एवं आभ्यन्तर	मूढगर्भ
द्राक्षा तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
नागवीर्य तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
नीलोत्पल तैल	५३९	बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रयोग	मूढगर्भ
पीतु तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
पुनर्वीर्य तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
प्रसाहिणी तैल	५३८	बाह्य एवं आभ्यन्तर	मूढगर्भ
फल तैल	४१३	अनुवासन बस्ति	रक्तगुल्म
बदरी तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धानी की व्याधियाँ
बलाका तैल	६६९	अभ्यङ्ग, पित्तु	धानी की व्याधियाँ
बला तैल	५३९, ५३४	बाह्य एवं आभ्यन्तर	मूढगर्भ

योग नाम	पृष्ठ-संख्या	प्रयोग-विधि	चिकित्स्य व्याधि
बला तैल	५४८	अभ्यङ्ग	सूतिका की परिचर्या
" "	५७२	अभ्यङ्ग, पान	सूतिकारोग
" "	६१५, ६२२	अभ्यङ्ग	नवजात शिशु
" "	६६५	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
" "	६६५	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
मधुक तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
मधुययी तैल	५३८	बाह्य एवं आप्यन्तर	मूढगर्भ
मीन तैल	६६९	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
राम्ना तैल	६६७	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
लाक्षादि तैल	३४०	अभ्यङ्ग	परिहार्य गर्भस्राव
बलु तैल	६६९	अभ्यङ्ग, पित्तु	धात्री की व्याधियाँ
वीरतर तैल	५३८	बाह्य एवं आप्यन्तर	मूढगर्भ
वृष तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
शतपाक बला तैल	५३१, ५३७	बाह्य एवं आप्यन्तर	मूढगर्भ
शतपुष्पा तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
शलावरी तैल	५३८	बाह्य एवं आप्यन्तर	मूढगर्भ
" "	६६८	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
रयोनाक तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
सहकार तैल	६७०	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
सहचर तैल	६६८	अभ्यङ्ग	धात्री की व्याधियाँ
सारस तैल	६६९	अभ्यङ्ग, पित्तु	धात्री की व्याधियाँ
सिद्धार्थकादि तैल	४६१	उत्तरबस्ति	अपरा-पातगर्भ
सैरयक तैल	५३८	बाह्य एवं आप्यन्तर	मूढगर्भ
हंस तैल	६६९	अभ्यङ्ग, पित्तु	धात्री की व्याधियाँ

वर्गीयधि साधित तैल-

जीवनीय गण	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका की परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका की व्याधियाँ
भौतिक द्रव्य	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका की व्याधियाँ
मधुर द्रव्य	२२२, २२३	अनुवासन बस्ति, पित्तु	गर्भिणी-परिचर्या
" "	२६६, २६७	अनुवासन बस्ति	गर्भिणी-उदवर्त
" "	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका की परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका की व्याधियाँ

योग नाम	पृष्ठ-संख्या	प्रयोग-विधि	चिकित्स्य व्याधि
वातहर द्रव्य	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका की परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका की व्याधियाँ
वृहणीय द्रव्य	५४९	बाह्य प्रयोग	सूतिका की परिचर्या
" "	५५८	बाह्य प्रयोग	सूतिका की व्याधियाँ
पाक			
अन्य नागर पाक	५७९	आप्यन्तर	सूतिकारोग
नागर खण्ड	५६९	आप्यन्तर	सूतिकारोग
पञ्चवीरक पाक	५६८	आप्यन्तर	सूतिकारोग
सौभाग्य शुण्ठी	५६९	आप्यन्तर	सूतिकारोग
योग-			
त्रैलोक्य योग	५६३	अभ्यङ्ग, पान, बस्ति	सूतिकाव्यापद्
वज्रकाञ्चिक योग	६५५	आप्यन्तर	स्तनग्रन्थ
रस-			
प्रतापलङ्केश्वर रस	५७९	आप्यन्तर	सूतिकारोग
वर्ति-			
फलवर्ति	४३२	स्थानिक	गर्भिणी का मलमूत्र-विक्रम

APPENDIX - II

LIST OF RECIPES

Though in the text, good number of recipes i.e. powders, decoctions, pastes, *ghritas* and oil etc. prepared with various drugs are referred, however, majority of these have not been given specific names, Here, in the list, only those having been referred with specific name or prepared with single or a particular group of drug are enlisted.

Name of recipe	Page No.	Method of use	Indications
Ariṣṭas—			
Abhayāriṣṭa	337	Oral	Pain in abdomen after abortion.
"	411	Oral	Raktagulma.
Ariṣṭa	575	Oral	Makkalla śūla.
Taktāriṣṭa	712	Oral	Slimy milk.
Awaleha—			
Kalyāṇakāwaleha	269	Oral	Diarrhoea during pregnancy.
Decoctions—			
Devadārvyādi	568	Oral	Sūtikāroga.
Hrībērādi	270	Oral	Diarrhoea during pregnancy.
Ghritas—			
Daśamūla	602	Oral	Fever due to ślesmā of a puerperal woman.
Phala	95	Oral	Prior to conjugation.
Gugulwādi	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuśka garbha.
Jivaniyā	583	Irrigation	Raktavidradhi.
Kākolyādi	408	Oral	Raktagulma.
Kalyāṇaka	411	Oral	Raktagulma.
"	602	Oral	Fever due to ślesmā of a puerperal woman.
"	606	Oral	Fever due to sannipāta of a puerperal woman.
"	663	Oral	Abnormalities of agni of dhātū.

Name of recipe	Page No.	Method of use	Indications
Karāñjādyā	583	Local	Raktavidradhi.
Mahākalyāṇaka	95	Oral	Prior to conjugation.
"	606	Oral	Fever due to sannipāta of a puerperal woman.
Mahāpaiśācika	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuśka garbha.
Maṅgalyaka	606	Oral	Fever due to sannipāta of a puerperal woman.
Pañcagavya	411	Oral	Raktagulma.
"	606	Oral	Fever due to sannipāta of a puerperal woman.
Pīpalyādi	413	Utarabasti	Raktagulma.
Śaṭpala	411	Oral	Raktagulma.
"	663	Oral	Abnormalities of agni of dhātū.
Tikta	600	Oral	Fever due to pitta of a puerperal woman.
Tiktaka	411	Oral	Raktagulma.
"	585	Oral	Raktavidradhi.
Tilwaka	585	Oral	Raktavidradhi.
Tittirādyā	600	Oral	Fever due to pitta of a puerperal woman.
Trāyamāṇa	585	Oral	Raktavidradhi.
Triphalā	695	Oral	Stanyadusṭi.
Vacā	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuśka garbha.
Ghritas prepared with group of drugs—			
Bhautika	559	External	Puerperal disorders.
Bitter	415	Anuvāsana basti	Raktagulma.
Candanādi	600	Oral	Fever due to pitta of a puerperal woman.
Garbhashāpana	240	Oral	Maintenance of pregnancy.
Jivaniyā	240	Oral	Maintenance of pregnancy.

Name of recipe	Page No.	Method of use	Indications
Jivaniya	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuṣka-garbha.
"	415	Oral, utara basti	Raktaagulma
"	552	External	Puerperal management.
"	559	External	Puerperal disorders.
"	583	External	Raktavidradhi
Madhura	94	Oral	Prior to conjugation.
"	224	Anuwāsana basti.	Antenatal care.
"	252	Oral	Striae gravidarum.
"	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuṣka-garbha.
"	552	External	Puerperal management.
"	559	External	Puerperal disorders.
Nyagrodhādi	583	Local	Raktavidradhi.
Patolādi	600	Oral	Fever due to pitta of a puerperal woman.
Sour	415	Oral	Raktaagulma.
Triphalā	695	Oral	Stanyadusti
Vājīkaraṇa	695	Oral	Stanyadusti
Vālahara	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuṣka-garbha.
"	552	External	Puerperal management.
"	559	External	Puerperal disorders.
Vṛṇhanīya	368	Oral	Upaviṣṭaka and upaśuṣka-garbha.
"	552	External	Puerperal management.
"	559	External	Puerperal disorders.
Pākas—			
Another nāgara pāka	571	Oral	Sūtikāroga.
Nāgara khaṇḍa	569	Oral	Sūtikāroga.
Pañcājīraka pāka	568	Oral	Sūtikāroga.
Saubhāgya śunṭhī	569	Oral	Sūtikāroga.
Rasa—			
Pratāpalañkeswara			
rasa	571	Oral	Sūtikāroga.

Name of recipe	Page No.	Method of use	Indications
Tailas or oils—			
Ādityapāṇī	538	Oral and external	Mūdhagarbha.
Anantā	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Ātī	669	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Atibalā	533, 538	Oral and external	Mūdhagarbha.
Badarī	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Balā	553, 534	Oral and external	Mūdhagarbha.
"	552	Massage	Puerperal woman.
"	572	Massage, oral	Sūtikā roga.
"	616, 623	Massage	New born.
"	665	Massage	Diseases of wet-nurse.
Balākā	669	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Dṛākṣā	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Fish	669	Massage	Diseases of wet-nurse.
Gudūcī	533, 538	Oral and external	Mūdhagarbha.
"	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Hamṣa	669	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Kadmbamaṣa	225	Anuwāsana basti	Antenatal care.
Kapitha	668	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Krañca	669	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Kuṣṭha	622	Local	Umbilical wound.
Lakṣādi	341	Massage	Threatened abortion.
Madhuka	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Madhyasū	538	Oral and external	Mūdhagarbha.
Nāgavīryā	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Nīlotpala	533	Oral and external	Mūdhagarbha.
Phala taila	413	Anuwāsana basti	Raktaagulma.
Pīlu	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Prasānī	538	Oral and external	Mūdhagarbha.
Punarnavā	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Rāsnā	667	Massage	Diseases of wet-nurse.
Sahacara	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Sahakāra	670	Massage	Diseases of wet-nurse.

अनुक्रमणिका

Name of recipe	Page No.	Method of use	Indication
Saireyaka	538	Oral and external	Mūdhagārbha.
Sārasa	669	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Śatapāka balā	533, 537	Oral and external	Mūdhagārbha.
Śatāpuspa	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Śatāwārī	538	Oral and external	Mūdhagārbha.
"	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Śyonāka	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Trikaṇṭaka	538	Oral and external	Mūdhagārbha.
Valgu	669	Massage, tampon	Diseases of wet-nurse.
Vīrataru	538	Oral and external	Mūdhagārbha.
Vīsa	668	Massage	Diseases of wet-nurse.
Oils prepared with group of drugs—			
Bhaṇṭika	559	External	Puerperal disorders.
Jīvanīya	552	External	Puerperal woman.
"	559	External	Puerperal disorders.
Madhura	223, 224	Anuvāsana basti, tampon	Antenatal care.
"	267	Anuvāsana basti	Udāwarta during pregnancy.
"	552	External	Puerperal woman.
"	559	External	Puerperal disorders.
Vāṭahara	552	External	Puerperal woman.
"	559	External	Puerperal disorders.
Vīrhaṇīya	552	External	Puerperal woman.
"	559	External	Puerperal disorders.
Yogas—			
Traivṛta yoga	563	Massage, enema, oral	Puerperal disorders.
Vajrakāṇṭhika	658	Oral	Stanyanāśa
Varti or suppository—			
Phalavarti	433	Local	Constipation etc. during pregnancy.

□

अ		अपरा पातन विधि		आम-गर्भ पात	
अकाल, प्रवाहण	४४७	अपरा पातन विधि	४५८	आम-गर्भ पात	३२९, ३१०
- प्रसव	४६५	- हस्त-निष्कासन	४६३	आतव	४०, ५७
- प्रसूता	५६४	अप्रगल्भ शिशु प्रसव	४६६	- उपस्थिति, बाल्यावस्था में	५७
- स्नेहन निषेध	३३७	अम्लपूर्ण व्याधि	६३६	- एकाकीकरण, धमनियों में	६३
- मूलागर्भ	५३१	अट्टि लक्षण	२८६	- का आग्नेयत्व, स्वरूप	६०
अङ्गस	४६	- उत्तम पुत्र के	२८८	- गर्भ लिङ्गोत्पत्ति, कारणभूत	४५
अचिरजात-गर्भ	४६७	- गर्भ के	२८६	- गर्भावस्था जन्म रक्तस्राव	४६
अचेष्ट बालक चिकित्सा	६११	- गर्भिणी के	२८९	- परिमाण	६०
- - - मन्त्र	६३०	अवरुद्ध प्रसव	४८१	- बाही धमनी	१४
अति प्रगल्भ शिशु प्रसव	४६८	अवस्थाये	३२	- विमोचनी धमनी	१४
अतिनिग्रथ सन्त्य दुष्टि,		- शारीरिक वृद्धि की	३२	- शुद्ध	६४
		- मायमावस्था	३२, ३४	- समगम काल स्राव	४५
देखे क्षीरदोष अष्ट		- बाल्यावस्था	३३	आयु, गर्भाधारण योग	८०
अनस्थि, गर्भ	५०	- बाल्यावस्था	३२	- रजोदर्शन	७९
अनागत, आर्वा	४४८	- वृद्धावस्था	३२, ३६	- रजोनिवृत्ति	७९
- प्रसव	४४५	- विशिष्ट स्त्री शरीर की	३६	- विवाह योग्य	७९
अनिरस्यमान गर्भ	४७८	- स्थिति दोषों की	३८	आर्वा	४३७, ४४१, ४४५
अन्तर्गर्भ	४३५, ४३९	अष्ट क्षीरदोष	६७४	- प्रभाव, प्रसव में	४४१
अन्तर्मुख सोतस्	१३	देखे क्षीरदोष अष्ट	आसन्न-प्रसवा	४३६, ४३९	
अन्तर्गर्भ	४७९	अष्ट मास में ओज	१५६	इ	
अपानाक	२७८, ३३२, ५५९, ५६१, ५६४	- - प्रसव प्रतिषेधार्थ कर्तव्य	१५८	इमेसिस ग्रेविडेस	२४७
अप्राज्ञाता	५६४	असम्प्राप्ता गर्भ	४७८	उ	
अप्राज्ञाता	३३७	असम्प्राप्ता गर्भ	४०, ४२	उपविष्टक गर्भ	३६१, ३८०
अप्राज्ञाता	१४१, ३२१	आम-गर्भ	३२०	- चिकित्सा	३६७
अपरा	४५७	- चिकित्सा	३३२	- दोष प्रकोप पर	३६८

उपविष्टकर्म, चिकित्सा	श्लोकाल उत्तरोत्तर रात्रि, गर्भाधान	१०	क्षीरदोषग्रह अतिशय, चिकित्सा ७१२
- - पालन	३७०	७४	- - निदान ६८८
- निदान, सम्प्राप्ति	३६९	७३	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८८
- प्रसव-काल	३६६	६२	- - गुरु / गौरव ६८६, ६८९
- लक्षण	३६९	७७	- - चिकित्सा ७१२
- - पित प्रकोप पर	३६६	७५	- - निदान ६८९
- - वाताधिक्य में	३६५	७६	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८९
- - स्तेयमा प्रकोप पर	३६६	७६	- - दौर्गन्ध ६८६, ६८८
उपशोषक	६२२	७६, ७७	- - चिकित्सा ७११
उपशुष्क गर्भ	३६३, ३८१	६३८	- - निदान ६८८
- चिकित्सा	३६७	६३८	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८८
- - दोष प्रकोप पर	३६८	-	- - पिच्छल ६८६, ६८८
- - पातन	३७०	७	- - चिकित्सा ७१२
- कारण, सम्प्राप्ति	३६३	६३३	- - निदान ६८८
- प्रसव-काल	३६६	कफ-जन्म स्तन्य-दुष्टि	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८८
- लक्षण	३६३	देखे स्तन्य दुष्टि	- - केनसङ्घात ६८६, ६८७
उपस्थ	७	कॉडिनल बन्धन	- - चिकित्सा ७०९
उपस्थ-गर्भ	७	कानियस मोल	- - निदान ६८७
उपस्थित-प्रसवा	४३६	कालातीत प्रसव	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८७
- - लक्षण	४३६	किक्कि	- - रक्त ६८६, ६८७
उल्बक	५३६	- - चिकित्सा	- - चिकित्सा ७१०
- चिकित्सा	५३७	- निदान, लक्षण	- - निदान ६८७
- लक्षण, सम्प्राप्ति, हेतु	५३६	कुक्षि	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८७
उल्ब	६१५	कुक्षि, सङ्ग	- - विरस / वैरस्य ६८६
- मार्जन	६१७	- ह्रासार्थ औषधि, प्रसवोपरान्त ६०८	- - चिकित्सा ७०९
ऋ	२८	किरटोरिस	- - निदान ६८६
ऋतुकाल	७१, ७७	क्षीरदोष ग्रह	- - पानोत्पन्न व्याधियाँ ६८६
- अर्वाधि	७१	- अतिशय	- - विवर्ण / वैवर्ण्य ६८६, ६८७

क्षीरदोषग्रह, विवर्ण, चिकित्सा	७११	गर्भ, के भाव, मातृज	१२८	गर्भ में कारणता, सात्त्व्य की	१३३
- - निदान	६८७	- - रसज	१३५	- - में कारणत्व का खण्डन	१३३
- - पानोत्पन्न व्याधियाँ	६८७	- - राजस	१३८	- - आत्मा के	१२५
क्षीरदोष, पञ्च	६७४, ६८९	- - शुभ अशुभ	१८७	- - माता पिता के	१२५
- अम्ल	६९०	- - सत्त्वज	१३७	- - रस के	१२६
- अल्प	६८९	- - सात्त्व्यज	१३४	- - सत्व के	१२७
- उष्ण	६९०	- - स्त्री, पुंश्व	१६४	- - सात्त्व्य के	१२६
- क्षार	६९०	एवं गुणसंक कर	१६४	- - में पञ्चमहाभूतों के स्रोत	११२
- घन	६८९	गर्भ के षड्वटक	११०	- - में मल अभाव कारण	१८६
ग	१०५	- षड्धातु	११०	- - में महत्त्व आत्मा का	१३१
- अङ्गवयव	११४	- षड्भाव	१२३	- - मोल	४१९
- आकाशीय	११४	गर्भ, कोमलस्थि युक्त	१८४	- - लिङ्ग निर्माण	१६९
- आग्नेय	११६	- कोष-फासङ्ग	५०५	- - वर्णोत्पत्ति	१६६
- जन्मोपरान्त उत्पन्न	१६६	- चिकित्सा	३७४	- - नेत्र की	१६८
- जलीय	११७	- लक्षण	३७४	गर्भ, सर्वप्रथम उत्पन्न अङ्ग	१५८
- पाञ्चभौतिक	११४	गर्भ, चलन चिकित्सा	३५२	- - स्वरूप, चतुर्थ मास में	१५२
- पार्थिव	११८	- - मासगुणसिक्त	३५२	- - द्वितीय मास में	१५०
- वायवीय	११५	गर्भ, जात्यन्धता	१६८	- - पञ्चम मास में	१५३
- अस्थि-विरहित	१८४	- परिभाषा	१०५	- - प्रथम मास में	१४८
- उत्पत्ति मातृजादि	१३३	- पोषण	१४३	- - षष्ठ मास में	१५४
समुदाय से	१३३	गर्भ में अवतरण, आत्मा का	१११	- - सप्तम मास में	१५५
- कार्य	१७२	- - पञ्चमहाभूतों का	१११	गर्भज वमन	२४६
- की गर्भाशयान्तर स्थिति	४३५	- - मन का	१११	- चिकित्सा	२४८
- के षट्क अङ्ग प्रत्यङ्ग के १६१	१६१	- - में कारणता, पिता की	१२९	- - कुम्भज	२५०
- के भाव, आत्मज	१३१	- - माता की	१२७	- - दोष प्रधान पर	२४९
- - तामस	१३८	- - रस की	१३५	गर्भजन्म, विषमयता	२९०
- - मित्रज	१२९	- - सत्व की	१३७	- - में गर्भयता	२९३

गर्भस्थ शिशु अरुद्व	१८५	गर्भस्राव उपद्रव चिकित्सा	गर्भाङ्गविकृति, आहारजन्य, पित्तल	१८२
गर्भपात ३२० (देखे गर्भस्राव भी)	- - -	अट्टु शोणित वेदना	३४७	- - -
- अर्पहर्य	३३१	- - -	अनाह	३४७
- अर्पण	३३१	- - -	गर्भमुखा	३४६
- असम्भविता	३३१	- - -	ज्वर	३४८
- कृत्रिम	३३१	- - -	दाहादि	३४८
- परिभाषा	३२०	- - -	मूत्रसङ्ग	३४७
- परिहार्य	३३१	- - -	वेदना	३४६
- प्रतिषेधार्थ वरण बन्ध	३५५	- - -	चिकित्सा	३३४
- प्रायिक	३३१	- - -	आचार, विहार	३४६
- सम्भावित	३३१	- - -	आमगर्भ स्राव	३३४
गर्भपातक औषधियाँ	६११	- - -	आमन्त्र्य में कठिनाता	३३३
- आयन्तर	६१२	- - -	परिहार्य	३३८, ३३९
- - - स्थानिक	६११	- - -	प्रसंसमान	३३८
गर्भस्थापक औषधियाँ	२३८	- - -	मासानुमासिक	३४९
गर्भवृद्धि	३७५	- - -	रक्तस्राव	३४५
- चिकित्सा	३७५	- - -	सिद्धान्त	३३८
- लक्षण	३७५	- - -	निदान	३३१
- मासानुमासिक	१४८	- - -	परिभाषा	३३१
- में पञ्चमहाभूतों का कार्य	११९	- - -	लक्षण	३३१
- में वायु की प्रधानता	१२१	- - -	प्रसंसमान	३३९
गर्भशोष	३५९, ३८०	- - -	सामान्य	३३९
- चिकित्सा	३६०	- - -	स्थानान्तर गमन	३३०
गर्भसङ्ग चिकित्सा	४५२	- - -	सम्प्राप्ति	३२८
गर्भस्थापक औषधियाँ	२३८	- - -	गर्भस्राव कारक औषधियाँ	६०८
गर्भस्राव	३२१	- - -	गर्भाङ्ग विकृति	१७६
- उपद्रव	३३१, ३३६	- - -	आहारजन्य	१८९
- - - चिकित्सा	३४६	- - -	विशेष	१८३

गर्भस्थ शिशु अरुद्व	१८५	गर्भस्राव उपद्रव चिकित्सा	गर्भाङ्गविकृति, आहारजन्य, पित्तल	१८२
गर्भपात ३२० (देखे गर्भस्राव भी)	- - -	अट्टु शोणित वेदना	३४७	- - -
- अर्पहर्य	३३१	- - -	अनाह	३४७
- अर्पण	३३१	- - -	गर्भमुखा	३४६
- असम्भविता	३३१	- - -	ज्वर	३४८
- कृत्रिम	३३१	- - -	दाहादि	३४८
- परिभाषा	३२०	- - -	मूत्रसङ्ग	३४७
- परिहार्य	३३१	- - -	वेदना	३४६
- प्रतिषेधार्थ वरण बन्ध	३५५	- - -	चिकित्सा	३३४
- प्रायिक	३३१	- - -	आचार, विहार	३४६
- सम्भावित	३३१	- - -	आमगर्भ स्राव	३३४
गर्भपातक औषधियाँ	६११	- - -	आमन्त्र्य में कठिनाता	३३३
- आयन्तर	६१२	- - -	परिहार्य	३३८, ३३९
- - - स्थानिक	६११	- - -	प्रसंसमान	३३८
गर्भस्थापक औषधियाँ	२३८	- - -	मासानुमासिक	३४९
गर्भवृद्धि	३७५	- - -	रक्तस्राव	३४५
- चिकित्सा	३७५	- - -	सिद्धान्त	३३८
- लक्षण	३७५	- - -	निदान	३३१
- मासानुमासिक	१४८	- - -	परिभाषा	३३१
- में पञ्चमहाभूतों का कार्य	११९	- - -	लक्षण	३३१
- में वायु की प्रधानता	१२१	- - -	प्रसंसमान	३३९
गर्भशोष	३५९, ३८०	- - -	सामान्य	३३९
- चिकित्सा	३६०	- - -	स्थानान्तर गमन	३३०
गर्भसङ्ग चिकित्सा	४५२	- - -	सम्प्राप्ति	३२८
गर्भस्थापक औषधियाँ	२३८	- - -	गर्भस्राव कारक औषधियाँ	६०८
गर्भस्राव	३२१	- - -	गर्भाङ्ग विकृति	१७६
- उपद्रव	३३१, ३३६	- - -	आहारजन्य	१८९
- - - चिकित्सा	३४६	- - -	विशेष	१८३

जरायु	३२१	जातहारिणी-लक्षण, कपालमालिनी	३१४	जातहारिणी-लक्षण, षष्ठी	३१३
- उत्पत्ति	१४१	- कर्कोटकी	३१५	- संतंशी	३१५
- दोष	३८७	- कलि	३१३	- सामान्य	३०८
जातकर्म	६१४, ६१७, ६१८	- कालरात्रि	३११	- स्तम्भिनी	३१२
जातहारिणी	२१३	- कुलक्षयकरी	३१५	जातन्मृता का कारण, गर्भ को	१६९
- आक्रमण, काल	२१४	- क्रोशना	३१२	जिनेटिक विकृतियाँ	१८१
- योय स्थिति	२१४	- चीडका	३१४	- व्याधियाँ	१८४
- भेद	२१५	- दुर्धरा	३११	जीव	१०५
- संक्रमण दृष्टि से	२१५	- नाकिनी	३१२	ड	
- - - तिक्ष्णी	२१५, ३०४	- परिश्रुता	३११	डिम्ब	१३
- - - देवी	२१५, ३००	- मिलिपिच्छिका	२१४, ३१४	डिम्बग्रन्थि	१७, २८
- - - मनुषी	२१५, ३०१	- पिशाची	३१२	डिम्बप्रणाली	२२, २५, २६
- - - साध्यासाध्या से	२१५	- पुण्यजनी	३१५	त	
- - - असाध्य	२१५, ३१४	- पुष्पजनी	३१०	ताप्रापास स्तन्य	देखे स्तन्यदृष्टि
- - - याय	२१५, ३१२	- पौरुषादिनी	३१५	द	
- - - साध्य	२१५, ३०१	- बडवामुखी	३१६	दिव्य गर्भ	३७६
- प्रवेश कारण	२१६	- भद्रकाली	३१४	दीर्घजिह्वी	२१४
जातहारिणी-तिरक्षीन	३०४	- भीरुका	३१३	दीर्घस्थ स्तन्यदृष्टि	देखें स्तन्यदृष्टि
- निराकरण उपाय	३०४	- मातङ्गी	३१४	दौहद	२०६
- प्रवेश विधि	३०४	- मोहिनी	३११	- उत्पत्ति का कारण	२०७
जातहारिणी-मानुषी	३०१	- यक्षी	३१३	- काल	२०६
- निराकरण उपाय	३०१	- याम्या	३१३	- जन्म वमन	२४६
- प्रवेश विधि	३०१	- रौद्री	२१४, ३१४	- पूर्ति, अपूर्ति परिणाम	२०९
जातहारिणी-लक्षण	३०८	- वर्धिका	३१४	- शिशु चरित्र प्रदर्शनकारी	२११
- अण्डजनी	३११	- वरया	३१४	ध	
- आसुरी	३१३	- वारुणी	२१४, ३१३	धमनियाँ अशोणाम्नी	१४
- इन्द्रवडवा	३१६	- विकुटा	३१०	धमनी	१४
- कटम्भरा	३१०	- शुष्करवती	३१०	- उर्ध्वगा	१४

धरा	१२	नागोदर, चिकित्सा	३६७	पुत्रोत्पत्ति सूचक लक्षण	२०३
धाम्नी	६४२, ६६१	नाग मन्त्रपादन परिणाम	६४८	पुष्प	४०, ४४
- अग्नि	६६२	नाभि-उपकल्पन	६२१	पूर्वकालिक प्रसव	४६६
- - विकार-चिकित्सा	६६३	- असम्यक्, से व्याधियाँ	६३३	पेशियाँ / पेशी	
- अजीर्ण जन्म व्याधियाँ	६६३	- - उगुण्डित	६३४	- अपत्यपथ	२१
- अनर्तव चिकित्सा	६६५	- - पिण्डलिका	६३४	- - आयुन्तर प्रसृत	२१, २३
- अपत्य	६९६	- - विजृम्भिका	६३४	- - मुज्जश्रित कर्तुलकार	२१
- की प्रकृति आदि का प्रभाव	६७९	- - विनामिका	६३४	- अर्तव प्रवेशिनी	२५, २६
- कुशला चिकित्सा	६६५	नाभिगत व्याधियाँ	६३३	- गर्भाछिद्र सञ्चित / सञ्चित	२१, २३
- क्षार प्रधान औषधि-निषेध	६६४	नाभिगुण्टी	६३४	- गर्भमार्ग की	२१
- चिकित्सा	६६१	नाभिपाक	६३३	- जननाङ्ग की	२१
- नित्यचर्मा	६६४	नाभिघ्न	६३५	- डाःटंस	२१
- पथ्य	६१५	नाभिशोथ	६३४	- बलचैकैर्वनोस्म	२२
- परिमित आहार	६६४	नामकरण संस्कार	६२८	- लक्षण एवं मुष्क, समकक्ष	२८
- परीक्षा	६४३	नैमेषहत गर्भ	३७६	- लिक्टैरुनी	२२
- महत्व	६६२	प		- शुक्रप्रवेशिनी	२६
- मिथ्याहारजन्य षष्ठी रोग	६७०	पञ्चक्षीर दोष	देखें क्षीरदोष	- शुक्रार्तव प्रवेशिनी	२१, २५, २६
- मेदोरोग चिकित्सा	६६५	परिप्लुत गर्भ	३७६	- स्तन-स्थित	२१
- वमनार्थ औषधि	६९५	पायोमेद्वा	५७७	- स्मिन्कट्टैर्वज्जानी	२२
- विरेचनार्थ औषधि	६९५	पिच्छिल स्तन्य दृष्टि	देखें स्तन्य दृष्टि	पैतिक स्तन्य दृष्टि	देखें स्तन्य दृष्टि
- शोथन चिकित्सा	६७१	पित्तज-स्तन्य दृष्टि	देखें स्तन्य दृष्टि	- बन्धन	२३
न		पुंसवन-कर्म	११०	प्रजापिनी लक्षण	४३६
नवजात शिशु, तत्काल परिचर्या	६१३	- उपयुक्त काल	११०	प्रजावरण-बन्धन विधि	३५५
- व्याधियाँ	६३२	- विधि	११२	प्रजास्थापन औषधियाँ	२३८
- - उपशीर्षक	६३२	पुत्रीय-विधि	११	प्रसव, अकाल	४४७
- - नाभिगत	६३३	- पूर्वकर्म, संयोग विधि	१२	- अतिप्रगल्भ शिशु	४६५
- स्नान विधि	६२२	- लाभ	१०३	- अनागत-कर्तव्य	४४५
नागोदर	३६३, ३८१	गुण्टि यज्ञ	१६	- अग्रगल्भ शिशु	४६५

प्रसव, अवस्थाओं के लक्षण	४३६	व	मर्म, पूरकवह	१६, १८
- आसन्न प्रसवा	४३६, ४३९	बह्नापयता	१७२ - योनि	१६, १७
- उपस्थित प्रसवा	४३६	- कारण	१७२ - शुक्रवह	१६
- द्वितीय	४३९	बाइनेव्युटिचन	१७४ - सेवनी	१६, १७
- परिवर्तित होने पर	४३८	बालक, सामान्य परिचर्या	६२३ - स्तनमूल	१६
- प्रजायिनी	४३६	बाला, रजोदर्शन पूर्व, परिवर्तन	६० - स्तनरोहित	१६
- प्रथम	४३९	बालावस्था	३२ मॉ:निना सिक्रिस	२४७
- प्रारम्भ होने का कारण	४२६	बाल्यावस्था	३२ मिथ्या गर्भ	३८३
- काल-सामान्य	४२३	बृहत्पगोष्ठ	२९ मूढगर्भ	४७८
- कालातीत	४६८	बौ:इ लिंगोमेट	- असाध्य, लक्षण	५०२
- परिचर्या	४४२	भ	- गतिर्या	४९०, ४९४
- अनागत प्रसव में	४४५	भा	- आसन	४९५, ४९६
- आसन्न-प्रसवा	४४२	भाशिश्निका	६, ७, २९	४९५, ४९६
- गर्भ के अवाक हो जानेपर	४५०	भूतहत गर्भ	३७६, ३८३	४९५
- विलम्ब होने पर	४५२	म	- - - - -	४९५, ४९६
- पूर्व, रक्तस्राव	४७०	मककल	५०५, ५७३	४९६, ५२१
- स्राव	४४९	- शूल	५७३ - चिकित्सा	५०८
प्रसवान्तराल	४३६	- चिकित्सा	५७३ - उपेक्षा परिणाम	५१४
प्रसवोत्सुका स्त्री	६०८	- निदान	५७३ - जीवित प्रसव विधि	५१०
- योनिगण्डिकाप	६०८	- लक्षण	५७३ - दोषिक	५१३
प्रसूता, योनिक्षत चिकित्सा	५७३	मदनातपत्र	६ - चित्तबन्ध परिणाम	५१४
- योनिप्रंश चिकित्सा	५७२	मध्यमावस्था	३४ - शल्योद्धारण	५१४
- स्नान	५५६	मनोभावगार मुख	७ - अधिपति की आज्ञा	५१६
फ	२८	मर्म, गुता	१७ - कठिनाइयाँ	५१४
फल	२८	- फलस्रोतस्	१६, १८ - पक्षत कर्म	५३०
फलयोगि, अपवृत्त	२८	- बस्ति	१६, १८ - स्त्री की स्थिति	५१७
- उद्वृत्त	२८	- मुक्करोत	१६, १७ - सिद्धांत	५०९
फेनसङ्घात सत्य दुष्टि	देखे सत्य दुष्टि	- मूत्रप्रेसक		

मूढगर्भ, चिकित्सा, ह्रास से आहरण	५१९	मूढगर्भ, निदान	४०१	योनि, पेशियाँ, बहिर्मुख, वर्तुलकार	२२
- चिकित्सिका / चिकित्सक	५०८	- लक्षण	४७५	- - - बहिर्मुख	६
- दोषिक	४९३	- सम्प्राप्ति	४७४	- प्रंश	४८६, ५०६, ५५९
- निदान	४८३	मैथुन, के अयोग्य स्त्री	८२	- चिकित्सा	५७२
- परिभाषा	४७८	- निषेध	८५	- संवरण	५०५
- भेद	४९१	- सामान्य स्थिति	८५	- संवृति	५०५
- कौल	४९१	मोल, कॉनियस	४९९	- सङ्ग	५०६
- परिध	४९२, ५२१	- हाइड्रोफोर्म	४९९	र	
- प्रतिचुर	४९२	य	४९२	रकागुलम	३८७
- बौजक	४९२	यमल	१७३	- उपद्रव	४०२
- संकीलक	४९१	- एक बीजतमक	१७४	- चिकित्सा	४०३
- लक्षण	४९०	- द्विबीजात्मक	१७४	- औषधियाँ आप्यन्तर	४०८
- सामान्य	४९०	युग्म गर्भ, पुत्र पुत्री का कारण	१७५	- प्रसवपूर्व रक्तस्राव में	४०५
- विक्रम	४९६	- पुष्ट, दुर्बल होने का कारण	१७६	- बस्ति	४१२
- शस्त्रकर्म	५२६	- सुख दु:खादि का कारण	१७४	- भेदन	४१३
- उदरपाटन	५३८	यूटरोसैकल बन्धन	२२	- योनि-विशोधक, मिचु	४१२
- पूर्व भोजन निषेध	५१५	यूटरोसैकल लिंगोमेट	२२	- - - - - वर्ति	४१२
- सिद्धान्त	५२६	यूनिओव्यूल ट्विन	१७४	- सिद्धांत, विशिष्ट	४०६
- शस्त्रकर्मार्ह	५२३	योनि	६	- - - - - सामान्य	४०५
- सम्प्राप्ति	४८७	- आकृति	७	- निदान	३८९
मूत्रसावी व्रण	१८	- अवर्त	७, ८	- पार्थक्य गर्भ से	३९९
- बस्ति गर्भाशयगत	१९	- गाढीकरणविधि, प्रसवोपरान्त	६०८	- पूर्वरूप	३९३
- बस्ति योनिगत	१९	- नाडियाँ	७	- में कारण, गर्भवत्प्रेषा का	३९७
- मूत्रनलिका योनिगत	१९	- गौरी	७	- दौहद का	३९८
मूढगर्भ	४७९	- चन्द्रमसी	७	- पाण्डुता का	३९८
- गर्भाशयान्तर	३८३, ४७९	- समीपणा	७	- युद्धि का	३९९
- चिकित्सा	४७७	- पेशियाँ	२२	- सत्योत्पत्ति का	३९८
- शल्योद्धारण के पक्षत	४७७	- - - आप्यन्तर प्रसृत	२३	- लक्षण	३९३

रक्तगुल्म, लक्षण, असाध्यता के	४०२	रूधिर	४०, ४४	शस्त्र, मण्डलाग्र	५२७
- सम्प्राप्ति	३८१	रेवती		सिशु की, आहार व्यवस्था	६२७
- सिन्धो में होने का कारण	३८८	रोमराजि	२०३	- परिचर्या, अन्य	६३१
रक्तवह स्रोतस्	६	ल		शुक्र	१०५
रक्तविद्राघ	५७६	लीनार्ग	३७१, ३८१	शुक्रधातु, स्त्री में	५०
- चिकित्सा	५७८	- चिकित्सा	३७२	शोणित	५७, १०५
- निदान	५७६	- निदान	३७१	श्रोणि	३
- लक्षण	५७६	- पातन	३७४	- अस्थिर्यौ	४
रक्षार्कर्म	६२३	- प्रसव काल	३७२	- गुहा	४
- षष्ठी यात्रि का	६२६	- लक्षण	३७१	- प्रमाण	३
रज	५७	लोहित	४०, ४४	- फलक	४
- निर्माण	५८	व		- माप	३
रजः काल	७७	वर्णवन्ध	३५५	- सन्धिर्यौ	५
रजःस्त्राव	४०, ४२, ४३, ४४, ६२	- उपदेवता	३५५	श्लेष्मज स्तन्य दुष्टि	देखे स्तन्य दुष्टि
- अन्तर्गत	६२	- विधि	३५६	ष	
- काल	६२	वातज स्तन्य दुष्टि		षट्धातु गर्भ की	११०
- के अन्त में परितर्शन	६१	वाताभिपन्न गर्भ	३५१	षट्धातात्मक गर्भ	११०
- में सम्भोग परिणाम	७०	- चिकित्सा	३६०	षट्शाल गर्भ के	१२३
रजःस्वला	३७	वातोदर	३७६	षष्ठी यात्रि-रक्षा-कर्म	६२६
- अञ्जनादि से हानि	६७	विप्रसव	४६६	- रोग, धात्री-मिव्याहार-जन्य	६७०
- चर्या	६५	विवाह योग्य आयु	७१	स	
रजोदर्शन, आयु	६१	विक्रम मूढगर्भ	४१६	सम्भोग	८२
- प्रसवोपपन्न, हेतु	५४५	वृद्धावस्था	३६	- क्षम आयु	८०
रजोनिवृत्ति आयु	६१	वैरस्य स्तन्य दुष्टि	देखें स्तन्य दुष्टि	- युग्मयुग्म दिवस में	८८
रजोमती	३७, ३८	श		- पुत्र, पुत्री जन्म कारण	८१
रजोवह स्रोतस्	७	शङ्कु	५२७	- रजःस्त्राव में, परिणाम	७०
रजोवाही स्रोत	१३	शस्त्र, अङ्गुलि	५२७	सूतिका	५४४
रुद्ध स्तन्यदुष्टि	देखें स्तन्यदुष्टि	- अर्धचन्द्र	५३०	- आस्थापन परिणाम	५५४

सूतिका, काल	५४४	सूतिका-चक्र, विशिष्ट चिकित्सा	५९५	सूतिकोश्यान	५५६
- नस्य परिणाम	५५४	- ग्राहोत्थ	६०६	स्तन असम्पत् जन्य दोष	६४६
- परिभाषा	५४४	- पित	५९८	- पान-विधि	६४७
सूतिकागार	४२७	- वात	५९५	- सम्पत्	६४६
- आकृति, निर्माण-विधि	४२८	- श्लेष्म	६००	स्तन्य	६३१
- निवास विधि	४३२	- साक्षिपातिक	६०२	- अपनयन-काल	६६०
- प्रवेश	४३२	- स्तन्योत्थ	६०६	- विधि	६२१
- संग्रहणीय पदार्थ	४३१	सूतिका-पथ्य पुत्र पुत्री जन्म में	५५६	- अपाव में अन्य दुग्ध	६५१
सूतिका-चक्र	५८५	- विदेशी जाति,	५५६	- क्षय	६५३
- कारण साक्षिपातिक के	५८७	सूतिका-परिचर्या	५४६	- चिकित्सा	६५४
- चिकित्सा-सिद्धान्त	५९१	- आनू देशस्थ	५५४	- लक्षण	६५३
- चिकित्सा-सूत्र, कफपित	५९३	- जाङ्गल देशस्थ	५५५	- जनन-द्रव्य	६५४
- रुक्ष-शरीर स्त्री	५९२	- मणिषाण	५४६	- नाश	६५३
- वात	५९३	- लाभ	५५४	- चिकित्सा	६५४
- वातपित्तलतक	५९४	- साधारण देशस्थ	५५५	- हेतु	६५३
- शोषनकर्म निषेध	५९४	- सामान्य	५४६	- निर्माण	६३१
- श्लेष्मापिष्यन्दी स्त्री	५९२	सूतिका-रोग	५६४	- प्रमाण	६४२
- साक्षिपातिक	५९४	- चिकित्सा	५६७	- प्रवृत्ति हेतु	६४०
- निदान	५८६	- निदान	५६५	- वृद्धि	६५८
- महत्त्व	५८५	- पथ्य	५७२	- चिकित्सा	६५१
- भेद	५८६	- लक्षण	५६५	- लक्षण	६५८
- लक्षण	५८९	सूतिका-व्याधिर्यौ	५५६	- शुद्ध लक्षण	६५१
- ग्रहोत्थ	५९१	- असाध्य होने का कारण	५५७	- सम्पत् लक्षण	६५१
- पित	५८९	- गणना	५५९	स्तन्यदुष्टि	६७२
- वात	५८९	- चिकित्सा	५५६	- अतिस्निग्ध	६८६, ६८८
- श्लेष्म	५८९	- सूत्र	५५८	- अभिघातज	६७४, ६८३
- साक्षिपातिक	५९०	- निदान	५६२	- कफज	६७४, ६८६
- स्तन्योत्थ जन्म	५९०	सूतिका व्यापद्	५५९	- कारण-सामान्य	६७२

INDEX

संस्कृत, क्षतज्ञ	६७४	संस्कृत-विक्रिया, तन्मुत्	७०८	संस्कृत, लक्षण, लाभभावभास	६८४
- गुरु	६८९	- लाभभावभास	७०८	- - भूशोण	६८५
- गौरव	६८६	- तिकानुरस	७०७	- - मधुर	६८४
- ग्रह-दूषित	६८३	- दृढज	७०६	- - लवणानुरस	६८५
- दौर्गन्ध्य	६८६, ६८८	- पित्तज	७०२	संस्कृत शोधक द्रव्य	६९७
- दृढज	६७४, ६८९	- फेनित	७०७	स्त्रीबीज	४१, ४२, ४३, ४४
- पिच्छिल	६८६, ६८८	- लवणानुरस	७०८	स्त्री की, मानसिक, अवस्था-प्रभाव	
- पित्तज	६७४, ६८६, ६८९	- वार्तिक	७००	गर्भ में	६९, १०१, १०२
- फेनसङ्घात	६८६, ६८७	- विच्छिन्न	७०७	- - स्थिति परिणाम	६९
- रक्ष	६८६, ६८७	- सान्निपातिक	७०६	स्त्रीयुक्त	४९
- वातज	६७४, ६७६	- सामान्य	६९७	स्मरमन्दिर	३, ४
- वौनस्य	६८६	- सिद्धान्त	६९२	स्मरतपत्र	६
- वैरस्य	६८६	- सत्य-दोषों के भेद	६७३	स्युडोसाईसिस	३८३
- वैवर्ण्य	६८६, ६८७	सत्य-पात, अपरिस्तुत	६४९	स्रोतस् आप्यन्तर	१३
- रतेष्वज	६८०	- गर्भणी का, प्रभाव	६८४	- आर्तवह	६, १३, ४७, १४१
- सन्निपातज	६७४, ६८२	- तैलवर्णदि प्रभाव	६५२	- बहिर्मुख	६, १३
- सम्प्रति	६९२	- दूषित, जन्य व्यधियौ	६७३	- मुष्क	१६
संस्कृत-विक्रिया	६९१	- नाना, परिणाम	६४८	- रक्तवह	६
- अतिडण	७०८	- वर्जित अवस्थायें	६५०	- रजोवाही	१३
- अम्लानुरस	७०८	- विभिन्न वर्ण-रस से विकार	६८४	- युक्तवाही	१३, १६, ५१
- कटुकानुरस	७०८	- लक्षण, अम्लानुरस	६८४	- संस्कृतवाही	१३
- कफजन्य	७०४	- - कटुकानुरस	६८४	ह	
- कषायानुरस	७०७	- - कषाय	६८४	हाइडेटिकोर्म मोल	४१९
- गुरु	७०८	- - गुरु	६८५	हाइड्रोमोसिस ग्रीविडेस	२४८
- ग्रथित	७०९	- - तन्मुत्	६८५	हीमेटोमेट्रा	४१८
- तनु, सान्द्र	७०८				

A					
Abnormalities, of amnion	387	āmagarbhā complications, of	334	Ambupūṣṭa vyādhī	636
of breast milk	672	monthwise	346	Amnionitis	387
of fetus,	179	prastāṣamāna	349	Amnion nodosum	387
of nipples,	647	sthānāntaragāmīa	338	Amniotic adhesion	387
teratologic	176	threatened	338	Anguli śāstra	527
Abortifacients	328, 608		338	Antarvidradhi	577
local	611	Accouchement force	441	Antenatal care	213
oral	612	effect of	441	amulet	217
Abortion	320	Accouchement ward	427	dietetics,	213
causes,	321	articles in	431	contraindicated	228
incubability of	332	shape, size, of	428	effect of	234
clinical features,	329	stay, in	432	mode of life,	213
general	329	Accoucher	508	contraindicated	228
prastāṣamāna	329	Accouchuse	447, 508	effect of	238
sthānāntaragāmāna	330	duties of	447	monthwise regimen	218
complete	331	qualifications, of	508	benefits, of	225
complication of	331	for maturity	79	for eighth month	222
definition of	320	for marriage	80	for fifth month	220
habitual	331	for menarche	79	for first month	218
incomplete	331	of menarche	61	for fourth month	220
induced	331	of menopause	61	for ninth month	224
inevitable	331	of menopause	61	for second month	219
in toxæmia of pregnancy	293	of menopause	61	for seventh month	221
pathogens	328	of menopause	61	for sixth month	221
threatened	331	of menopause	61	for third month	219
treatment,	334	of menopause	61	water for bath	217
after stability	346	of menopause	61	Antepartum hæmorrhage	470
		of menopause	61	Aparā	142
		of menopause	61	Aparvīta phala-yoni	30

Ardha candra śāstra	530	treatment	709	effect of	447
Ārtava	40	picchila	686, 688	instructions for	447
āgneya character of	60	clinical manifestations	688	Bhaga	5
amount of	60	etiopathogenesis	688	Bhūahṛta garbha	376
functions of	60	treatment	712	contradiction of	379
vaha srotas	13, 49, 142	rukṣa	686, 687	treatment	378
vāhī dhāmānī	13, 14	clinical manifestations	687	Body complexion	166
Arteries, tending, downwards	14	etiopathogenesis	687	factors for	166
upward	14	treatment	710	formation	166
menmāry	16	vairasya / virasa	686	Breast milk	638
ovarian	16	clinical manifestations	686	abnormalities, of	672
uterine	16	etiopathogenesis	686	formation of	638
Āsanna-prasavā	436	treatment	709	normal characteristics	651
Aspiration pneumonia	637	vivarṇa / vaivarṇya	686, 687	Breasts	646
Asik	40, 42	clinical manifestations	687	abnormalities due to	
Aṣṭa kṣīra doṣa	675, 686	etiopathogenesis	687	imperfect	646
atimigdhā	686, 688	treatment	711	diseases with	
clinical manifestations	688	Ātmā, descent, of	111	unexpressed	649
etiopathogenesis	688	features developing from	131	feeding method	647
treatment	712	in embryogenesis	131	merits, of	646
daugandhya	686, 688	Ātmaja bhāwas	109, 131	Broad ligaments	26
clinical manifestations	688	Āvis	441	C	
etiopathogenesis	688	B		Caputsuccedaneum	633
treatment	711	Bad signs/symptoms	286	Cardinal ligament	26, 31
guru	686, 689	indicating death,		Care of newborn	613
clinical manifestations	689	of child	288	Carneous mole	422
etiopathogenesis	689	of fetus	287	Causes of birth of female	89
treatment	712	of pregnant woman	289	of male,	89
phenasaṅghāta	686, 687	Bālāwasthā	33	Cephalic version	523
clinical manifestations	687	Bath of neonate	622	Cephalo-pelvic disproportion	497
etiopathogenesis	687	Bearing down	447	Cervical dystocia	508
				Cesarean section	538

Chardi	246, 247	effect, of non-fulfilment	209	Embryo body parts,	
āgantujā	247	period	206	derived from ātmā	131
dauhṛda janya	247	Dauhrīnī	206	father	129
doṣaja	247	Daurgandhya milk		mother	128
dwiṣṭārthajā	247	see aṣṭakṣīra doṣa		rajas	138
garbha janya	247	Delivery, līna-garbha, of	372	rasa	135
Childhood	33	upāśuṣka, of	366	sālmnya	134
Clitoris	6, 8, 30	upaviṣṭaka, of	366	satwa	137
Coition days	88	Destructive operations	526	tamas	138
for female	88	Dhāmānī, Dhāmānīs	14	Embryo, definition, of	105
for male	88	adhoga	14	descent, process, of	106
Coitus, contraindicated		ārtavavāhī	14, 15	descent, sequence, of	111
conditions, for	82	ārtavavimocanī	15	ātmā, of	111
menstruation, during	70	Dhātī	642	mana, of	111
posture abnormal, during	85	cikitsā	661	pañcamahābhūtas, of	111
posture normal, during	85	importance, of	662	development of	148
Conception, age, of	80, 81	parikṣā, of	643	first month, in	148
essential factors, for	86	Dirghajīvitī	294	second month, in	150
rituals, for	91	Discoloration of milk,	686	third month, in	151
specific acts, for	91	Divya garbha	378	sources of pañcamahābhūtas	112
Congenital blindness		Dohṛda	206	Embryogenesis, factors,	
cause of	168	Drugs beneficial for		ātmā, as	131
Conjugation method	92	E	238	father, as	129
Contraceptives	608	Effect, āvis, of	441	mother, as	127
local	609	lactation by different		rasa, as	135
oral	610	women, of	648	sālmnya, as	133
Craniotomy	527	milk with cereals, of	648	satwa, as	137
D		over child, psychological		contradiction of, only	
Dauhṛda	206	status, of	69	ātmā	125
cause of	207	over fetus psychology, of	101	mother and father	125
denoting characters		Eight disorders of milk		rasa	126
of child	211	see aṣṭakṣīra doṣa			
effect, of fulfilment	209				

sāmya	126	effects of mother's diseases of	187	general	352
salwa	127	factors for delivery of full term	188	monthwise	352
Emesis gravidarum	248			Garbha, colour of eyes, of	168
Endometrium	26	Fetus,		congenital blindness, of	168
Endosalpinx	26	features aśubha, of	187	definition, of	105
Epochs of life	36	features sex, of	164	formation with maternal etc. components, of	123
status of dosas in	39	features śubha, of	187	functions, of	172
Evisceration	529	first born body part,	158	Garbha kosparāśaṅga	504, 507
Excessive unctuous milk	686, 688	intrauterine death of, see mṛta garbha		Garbhakṣaya	374
F				clinical features, of	374
Factors for sex formation	169	situation of	188, 434	treatment, of	375
Fallopian tubes	26, 28, 31	monthwise development, of	148	Garbhapāta	see abortion
Father in embryogenesis	129	in fifth	153	Garbhasaṅga	452
body parts from	129	in fourth	152	treatment of	452
Female śukra	49	in seventh	155	Garbhaśoṣa	359, 383
Fetal cry, absence of	185	in sixth	154	Garbhasāṅva	see abortion
Fetal development	119	ojas in eighth months, of	156	Garbhashthāpaka drugs	238
functions of pañcama-habhūtas in	119	saddhātu of	110	Garbha, vāābhiṣanna	359
importance of vāyu, in	121	why does not cry	185	Garbhavṛddhi	375
Fetal excreta, absence of	186	why does not excrete	186	clinical features	375
Fetal nourishment	143	Fistula, urethrovaginal	20	treatment	375
Fetus, see also embryo		uterovesical	20	Garbhāśāya	12, 13
bhaufika components	114	vesicovaginal	20	Garbhavyāpat	321
from agni	116	Foul smell of milk	686, 688	Garbhīṇī-atisāra	268
from ākāśa	114	Frothy milk	686, 687	etiology	268
from jala	117	G		treatment, āmāśāra of	270
from pṛthvī	118	Garbha, body complexion, of	166	general	269
from vāyu	115	body parts after birth, of	166	in dominance of kapha	271
boneless	184	Garbha chālana, treatment of	352	pitta	272
constitution of body parts, of	161			vāta	272

principles, of	269	āsuri	313	punyājani	315
with blood	273	badāvāmukhī	316	pūspaghnī	310
with fever	270	bhadrakālī	314	raudhī	294, 314
Garbhīṇī-jwara		bhīrukā	313	sādhya	295
see pregnant woman fever		caṇḍikā	314	śakunī	305
Garbhīṇī viśama jwara	265	catuspadī	304	sandamśī	315
Garbhodaka	437, 636	causes of affliction, by	296	sarpā	305
Garbhopaghātākara		clinical features, of	308	śaśthī	313
bhāwas	228	curable	295, 309	stambhīnī	312
Guru milk	686, 689	daivī	296, 300	śuṣkarevatī	310
H		durdharā	311	tiraścina	296
Heavy-milk	686, 689	incurable	295, 314	vanaspati	304
Hydatiform mole	422	indravadavā	316	vardhikā	314
Hydramnios	387	kālārātri	311	varṇā	296, 301
Hyperemesis gravidarum	248	kali	313	varāntarā	296, 301
I		kapālamālinī	314	vāruṇī	294, 313
Infected hematoma	578	karkotakī	315	vaśyā	314
external	578	kārukī	296, 301	vikūā	310
internal	578	kaṭambharā	310	yakṣī	313
Insipidity of milk	686	krośānā	312	yāmyā	313
Intermenstrual period	62	kulaṣayakarī	315	yāpya	295, 312
Internal mammary veins	16	liṅginī	296, 301	K	
Inter-pregnancy-period	607	mānuṣī	296, 301	Kandarpagetha	8
Intrapartum haemorrhage	507	mātāṅgī	314	Kikkisa	241
Intrauterine death	286, 471	mātsī	304	treatment	242
see mṛtagarbha		mohinī	311	L	
Inversion of uterus	572	nākinī	312	Labia majora	26, 31
J		parisrutā	311	Labia minora	26
Jarāyu	142, 387	pauruṣādīnī	315	Labour	424
dosā	387	period for seizure, by	294	causes, of onset	426
Jārahārinī	293	pilipicchikā	294, 314	delayed	452, 468
aṇḍaghñī	311	piśāci	312	treatment of	452
asādhya	295, 314				

fetus during management, of	434	for expulsion	374	age of	61
after descent	442	Linea nigra	200	changes before	60
āsanna prasawā	450	Liquor amni	437, 636	Menstrual cycle	62
failure in descent	442	Lohita	40, 44	Menstruation	62
first stage, during	445	M		coitus, effect during	70
normal gestational period, for	442	Madanāpatra	6, 8	duration of	62
normal situation of fetus during	424	Madhyamāwashā	33	mode of life during	65
obstructed see mūdhagarbha premature	507, 573	Makkalla		normal character of	64
Labour, stages	434	śūla	573	reappearance after delivery	545
clinical features, of	466	clinical features	573	Middle age	34
after descent	436	etiology	573	Milk-breast	638, 672
after parivartana of garbha	436	treatment	574	abnormalities of	672
āsanna prasawā	438	Mana, in embryogenesis	137	amount of	642
prajāyini	436	features developing from	137	cessation, causes of	653
prasavotsukā	436	Māṇḍalāgra śāstra	527	diseases by vitiated	673
upasthita prasawā	436	Manobhāgāramukha	8	disorders classification of	673
Labour untimely	436	Marma	19	disorders five	689
Laparotomy	465	basti	19, 20	alpa	690
Lie transverse	538	guda	19, 20	amla	690
Ligament, cardinal	501, 502	muṣkasrotas	19	ghana	690
pubocervical	26, 31	mūtrapraseka	19	ksāra	690
transverse cervical	25, 31	mūtravaha	19, 20	uṣṇa	690
uterosacral	25, 31	phalasrotas	19	effect on child,	676
Linagarbha	26, 31	sevanī	19	colours, of	652, 685
clinical features	371, 385	stanamūla	19	physical characters of	676
etiology	371	stanarohita	19	tastes of	685
period of delivery	372	śukravaha	19	ejection, causes of	640
treatment	372	yonī	19	formation of	638
	372	Marriageable age	79, 81	substitute	659
	372	Mātrja bhāwās	109	Milk-fever	590
	372	Menarche	60		

treatment	606	etiology	471	pathogenesis, of	487
Milk purifying drugs	697	pathogenesis	474	positions, of	490
Milk-vitiated, by		treatment	477	dorsoanterior	501, 502
abhiḥṭā	675, 683	after extraction	477	dorsoposterior	501
grahas	675, 683	Mūdhagarbha	471, 478	presentations, of	490, 494
pitta	675, 677	classification, of	491	brow	501
ślesmā	675, 680	clinical features	490	complete breech	501
three dosas	675, 682	bijaka	492, 501	compound	501
trauma.	675, 683	dosika, of	493	cord	501
two dosas	675, 681	incurability of	502	face	501
vāta	675, 676	kila	491, 501	footlings	500, 501
Milk-vitiation,	672	parigha	492, 501	incomplete breech	500
etiopathogenesis, of	672	pratikhura	492, 501	surgical intervention for	510
treatment, of	691	sankhaka	491	consent of guardian	516
caused by, all dosas	706	definition, of	478	treatment	508
two dosas	706	destructive operations	526	alive of	510
vāta	700	general principles	526	dosika, of	513
due to kapha	704	method of	527	effect of delay in	514
pitta	702	effect of rending alive	525	general principles	509
general	697	etiology, of	523	Multiple pregnancy	172
principles, of	692	extraction	514	factors for	172
tastes etc. caused by		difficulties in	514	N	
kapha	708	laparotomy, for	538	Nābhipaka	633
others	708	manual	519	Nābhiśoṭha	634
pitta	707	position of woman	517	Nābhiṇḍī	634
vāta	707	postoperative management	530	Nādis of yoni	7
Molar pregnancy	422	fit for instrumentation	523	cāndramasi	8
Morning sickness	248	gaites of	494	gaurī	8
Mother, in embryogenesis	127	lie transverse	502	samīrāṇā	8
fetal parts, from	128	method of delivery with	510	Nāgodara	363, 384
Mṛta-garbha	471	medicine	510	treatment, of	367
clinical features	475	Nāgamaśarīra garbha	376		

Naming ceremony	628	laksana, of	21, 28	drugs beneficial, for	238
Neonate, bath, for	622	muska, of	27	Pregnancy-disorders	241
feeding schedule, of	627	outer circular	27	treatment of	
New-born child	613	spreaded inside	27	ākṣepaka	278
care after birth, of	613	śukrapaveśinī	24	anal fissure	277
diseases due to impro-	632	Phala	29	anal pain	277
per care, of	632	Phalayani	30	anorexia	275
general nursing care,	623	Phalayani udvṛita	30	apātānaka	278
of	623	Plenasanṅghāta milk	30	bleeding diathesis	285
rakṣākarma, of	623	see aṣṭakṣīradoṣa		cardialgia	280
resuscitation, of	619	Picchila milk		constipation	275
mantra, for	620	see aṣṭakṣīradoṣa		convulsive disorders	278
Non-unctuous milk,	686, 687	Piṇḍa bhāwas	109	cough	281
Nursing care of child	623	Placenta, formation	141	dryness of mouth	283
O		expulsion normal	457	dyspnoea	282
Obstructed labour	471	Placental retention		edema	284
Old age	36	complication, of	457	grahaṇī	275
Orifice external	6	treatment, of	458	gūlma	276
Ovarian hormones	46	external manipu-	458	hiccup	283
Ovum	41, 42	lation, for	459	inflammation	284
P		use of drugs, for	459	jaundice	280
Paripṛatagarbha	378	manual removal, of	463	pārśwagraha	278
Pelvic abscess	578	oral medicines, for	462	poison	285
Pelvic cavity bones	4	Polyhydramnios	387	pravāhikā	274
Pelvis	3	Position, dorsoanterior	501, 502	principles, of	242
joins of	5	dorsoposterior	501	gestational months	
normal measurement, of	3	Postmaturity	468	in	244
Peśī, peśīs	20, 26	Prajāsthāpana drugs	240	retention of urine	283
apatyapatha, of	21	Prajāvaraṇa bandha	356	rigidity of flanks	278
ārtava-praveśinī	24	Pregnancy, breast changes,	205	skin disorders	284
breasts of	26	in	205	snake bite	285
garbhachidra, of	21, 27	diarrhoea, during	268	stomatitis	278
mārga of	21	see garbhini atisāra			

udāvarta	266	effect of cleansing	255	raktavidradhi	576
Pregnancy, heartburn	286	measures	255	śūṭikāroga	565
Pregnancy signs/symptoms	197	general	260	utero-vaginal prolapse	572
after conspicuousness of		principles before	254	vaginal ulcer	573
body parts	198	fourth month	254	yonibhramśa	572
denoting fetal sex	203	after fourth	255	yoniksata	573
gestational period, in	201	month		treatment	563
fifth month	201	wine addict	265	principles, of	567
fourth month	201	Premature labour	466	Puerperal-fever	585
seventh month	202	Presentations,	500, 501	aggravation of	588
sixth month	202	abdomen	501	causes of sānnpātika	587
immediately conceived		breech, complete	501	classification	586
woman	197	incomplete	500	clinical features	589
sadyograhita garbhā	197	brow	501	due to grahas	591
twin	205	compound	501	milk	590
vyakta-garbhā	198	cold	501	pīta	589
Pregnancy toxæmia	290	face	501	sānnpātika	590
Pregnancy-vomiting	246	footling	501	śleṣmā	589
treatment, of	248	vertex	501	vāta	589
according to doṣa	249	Pseudocycsis	387	etiology	585
due to pīta	249	Psychological status, effect	69	importance of	585
śleṣmā	250	of		treatment	591, 595
vāta	249	Pubocervical fascia	26, 31	Puerperal pyometra	577
principles, of	248	Pubocervical ligament	25, 31	Puerperal woman, bath for	556
recipes, for	248	Puerperal after pains	573	cleansing measures	594
Pregnant woman, fever of	254	Puerperal disorders	559	contraindications	594
etiology	254	etiology	562	indications	594
treatment, according		incurability causes, of	557	definition of	543
to doṣa	260	number	559	diseases of	556
caused of pīta	262	specific	564	management of	546
śleṣmā	264	inversion of uterus	572	according to sex	556
vāta	260	makkalla	573		
complications of	265				

amulets for benefits of for foreigners general care	546 554 556 546	differing features etiopathogenesis prodromal symptoms prognosis	400 389 393 402	Rūmañ. characteristics, of 73 contraindications for 76 Rūvyañña kāla 76, 78 Rudhira 40, 44
specific for place of living treatment, principles of	554 558	treatment of appropriate period for basī for bhedana	403 403 412 413	Rukṣa milk see aṣṭakṣīradosa Ś Śaṅku 527
Puerperium, duration of Pūṃsawanakarma appropriate period for methods of	543 190 190 192	for bleeding, after expulsion before expulsion before labour	414 414 414 405	Śaṣṭhī disease of wet nurse 670 Śaṣṭhī rātri, protective measures, in 626 Śastra, aṅguḷi 527
Puṣpa Putreṣṭiyajña Putrīvaidhi, benefits, of	40, 44 96, 97 103	oral medicines for principles, general in doubt specific	408 405 405 407	ardhaacandra 530 maṇḍalāgra 527 Sāmya in embryogenesis 133 Sāmyajña bhāwas 109
R Raja formation since childhood	40, 42, 56 58 57	separation of vaginal pessary, for why increases	413 412 399	Satwa, in embryogenesis 137 features from 137 Show, colour of 441
Rajah kāla Rakṣākarma on 6th night of birth	78 623 626	Raktavidradhi clinical features etiology	576 576 576	Slimy milk 686, 688 Smaramandira 6 Smarāpātara 6
Rakṣogghna drugs Rakta Raktagulma	626 40, 42 387	treatment Rasa in embryogenesis Rasaja bhāwas	578 135 109	Śonita 40, 42 Śrotas-ārtava vaha 13, 49, 142 Stages of labour see labour
cause of, appearance of anaemia dohṛda milk	398 398 398	Resuscitation of child Retention of placenta see placenta	619 619 619	Stanasampat 646 Stanya, amount of 642 āpanayana kāla 660
only in females resemblance with fetus	388 397	Revatī see jātahāriṇī Romarājī 61, 200, 205 Rūkālā 71, 76, 78	619 205 78	āpanayana vidhi 661 formation 638 janana drugs 654
clinical features complications of	393 402	duration effect of impregnation, in 90	71 90	pravṛtti, causes of 640 sāmpat 651

Stanyaksaya	653	pitta	182	Upaśrṅsaka	632
clinical features	653	tridosa	183	Upasthagarbha	8
treatment	654	vāta	181	Upaśuśka garbha.	363, 384
Stanyanāśa	653	Toxemia of pregnancy	290	clinical features	363
causes	653	Transverse lie	501, 502	domination of pīta, in	366
treatment	654	Twin	174	śleṣmā, in	366
Stanyavrdhi	658	see also multiple pregnancy		vāyu, in	365
clinical features	658	binovular	174	etiopathogenesis	363
treatment	659	causes of specific sex, in	175	time of delivery	366
Striae gravidarum	241	uniovular	174	treatment	367
Strī śukra	56	U		abortifacient	370
Substitute milk	659	Udvyta phalayoni	30	general	367
Śukra, female	49, 50	Ulbaka	636	specific for doṣa	368
Śukravaha srotas	19	clinical features	636	Upviśiśta garbha	361, 384
Śutikā	543	etiopathogenesis	636	clinical features	361
definition, of	543	treatment	637	domination of	
kāla	543	Ulba	616	pīta, in	366
Śutikāgūra		Umbilical cord	621	śleṣmā, in	366
see accouchement ward		diseases, treatment of	633	vāyu, in	365
Śutikā jwara		method of cutting, of	621	etiopathogenesis	361
see puerperal fever		growth after		time of delivery	366
Śutikāroga	564	detachment	635	treatment	367
beneficial diet, in	572	if does not fall	635	abortifacient	370
causes	565	ulcer, treatment of	635	general	367
clinical features	565	suppuration, of	633	specific for doṣa	368
treatment	567	Umbilicus-diseases of	633	Uterosacral ligaments	26, 31
T		inflammation of	634	Uterus	10, 12
Tama, features derived from	138	piṇḍalikā	634	corpus, of	24, 27
Teratologic abnormalities	176	uttuṇḍita	634	fundus, of	24, 27
causes, of	176	vijambhikā	634	isthmus, of	24, 27
due to diet vitiating		vināmikā	634	V	
kapha	182	Uniovular twins	174	Vagina	6

after delivery constriction of	608	Vṛddhāwasthā	33	prakṛti, effect on child	671
introitus, of	27	Vulva	5	purgatives for	695
Vaginal introitus	7	W		purifying measures, for	671
Varanabandha	355	Weaning method	661	treatment, of	661
benefits of	355	Weaning period	660	amenorrhoea	665
method of	356	Wet-nurse	642	emaciation	665
period of	355	amount of milk, effect on child	671	obesity	665
Vātābhipanna garbha	359	congenial diet, for	695	Woman, unfit suckling for	650
etiology and clinical features	359	contraindication for ksāra	664	Y	
treatment	360	daily routine, of	664	Yoni	7
Vātodara	376	diseases caused by ajīrna, to	663	āvartas of	9, 10
Veins	16			bhṛaṇśa	508
Vernix caseosa	616	digestive capacity, of	662	nāḍi, of	7
Virasa milk, treatment, of see aṣṭakṣīra doṣa		emetics, for	695	cāndramasī	8
Viṣkambha mūḍhagarbha	502	examination, of	643	gauṛī	8
Vital parts	16	importance, of	662	sanīraṇā	8
Vivarna milk, treatment, of see aṣṭakṣīra doṣa		limited diet, for	664	saṃvaraṇa	507
		non-congenial diet, for	696	saṃvṛti	507
		parity, effect on child	671	saṅga	508
				shape of	7

